

Tomo II — Blocco Regionale (Linea B, 4 blocchi macro-territoriali)

Psicologo di Base — Studio Integrale HTA

Studio Integrale, Finale e Definitivo

Tomo II — Estensione Nazionale del modello «Psicologo di Base»

Dalla riforma pugliese (Legge Regionale 11/2023) all’istituzionalizzazione nazionale: i sistemi sanitari regionali, gli studi di valutazione delle tecnologie sanitarie delle venti regioni, la leva formativa e digitale

Autore intellettuale e concettuale: **dott. Luigi De Michele**, psicologo — Capurso (BA)

Edizione consolidata per tranches progressive · Tranche 3 (Blocchi I–IV, diciannove regioni) · Luglio 2026

Avvertenza di edizione del Tomo II

Il presente Tomo II consolida l'estensione nazionale del modello «Psicologo di Base», in edizione per tranches progressive. La presente Tranche 3 completa il consolidamento dei materiali disponibili: la Sezione Nazionale — nel solo corpus conforme al regime probatorio dell'opera — e i quattro Blocchi Regionali, per un totale di diciannove studi integrali di valutazione delle tecnologie sanitarie (Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia nello stato parziale disponibile, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta), condotti sul telaio HTA internazionale con i medesimi vincoli metodologici invariati del Tomo I: duplice intervallo di Chisholm e collaboratori (2016) quale unico ancoraggio di rendimento; caveat del trial IMPACT; verdetto tripartito mai aggregato; regola di non duplicazione; graduazione simmetrica GRADE; Intelligenza Artificiale come leva abilitante subordinata. Le rare occorrenze di rapporti semplificati entro gli studi regionali sono smentite critiche delle semplificazioni comunicative, non affermazioni dell'opera. Lo studio della Puglia non è riprodotto nel presente tomo, essendo esso l'oggetto integrale del Tomo I, al quale si rinvia. Restano esclusi dall'integrazione testuale, con scelta deliberata, i documenti nazionali della fase anteriore — la sintesi nazionale di prima generazione, le venti schede regionali di prima generazione, la traccia di legge nazionale, il fascicolo unico nazionale e la relazione sui risparmi indiretti — in quanto recano come affermazioni positive rapporti di rendimento superati dal regime probatorio dell'opera; la loro funzione è assolta, in forma conforme, dagli studi regionali di seconda generazione qui consolidati. Con la presente Tranche 3, gli studi delle regioni Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta sono stati acquisiti e integralmente consolidati nei rispettivi Blocchi Regionali, sul medesimo telaio metodologico e con il medesimo ancoraggio a Chisholm e collaboratori (2016) delle quindici regioni già presenti: la copertura nazionale del Tomo II risulta con ciò completa per tutte le diciannove regioni trattabili nel perimetro dell'opera (esclusa la sola Puglia, oggetto del Tomo I).

La terza tranche di integrazione, resa possibile dal recupero del testo nativo dalle stampe d'archivio, aggiunge alla Sezione Nazionale il telaio integrato dello studio regionale — l'architettura definitiva per l'estensione a tutte le regioni — e il capitolo ricalibrato sull'impatto economico, organizzativo e di sistema del Servizio a livello nazionale, che procede per scalatura ragionata del modello pugliese già quantificato, senza ricorso ad alcun rapporto non ammesso. Restano escluse, con dichiarazione, la sintesi nazionale di prima generazione, per affermazione positiva di rapporti superati, e la traccia di presentazione per i decisori, quale apparato di comunicazione politica di parte estraneo al perimetro scientifico. Per pronunciamento dell'autore, l'ancoraggio di riferimento dell'intera opera, in questo Tomo II come nel Tomo I, resta il duplice intervallo di Chisholm e collaboratori (2016): è questo l'unico rapporto di rendimento adottato quale riferimento per l'iter legislativo nazionale e regionale, in ogni studio regionale qui consolidato. Il quadro OCSE 2026 è stato esaminato in fase di revisione come possibile schema di governo comparativo, ma non è stato adottato quale strato sostitutivo dei valori qui riportati: la sua trattazione, a fini di trasparenza storica e comparativa, è consolidata nel Tomo I (Appendice IV, § 6, «Nota storica: il quadro OCSE 2026 come riferimento comparativo»), alla quale si rinvia per ogni approfondimento in merito. L'apparato fondato su Chisholm e collaboratori (2016) resta, senza eccezione, l'unico strato di rendimento affermato nel presente tomo.

Come leggere questo Tomo (Linea B — Blocchi Regionali macro-territoriali)

Questo volume è la seconda linea editoriale del Tomo II Nazionale: aggrega le regioni italiane (Puglia esclusa, trattata a piena profondità nel Tomo I) in quattro Blocchi Regionali macro-territoriali — Italia settentrionale, centrale, meridionale, isole e regioni residue — con un'analisi economica e organizzativa più estesa di quella sintetica per singola regione della prima linea editoriale (“tomo-2-nazionale/opera-unificata-nazionale-e-ue27.docx”, i Volumi 2–21). Le due linee sono prodotti distinti e complementari, non l'una sostitutiva dell'altra: la relazione esatta tra i due livelli di dettaglio è ancora da definire in una fase successiva (si veda “_meta/status-tracker.md”).

Non è pensato per essere letto per intero: ogni Blocco Regionale tratta un raggruppamento di regioni con caratteristiche territoriali affini, secondo lo stesso schema analitico applicato dall'opera alla Puglia. La mappa che segue indica, per ciascun profilo di lettore, quali sezioni consultare.

Mappa dei destinatari

Profilo del lettore	Sezioni di riferimento	Perché
Decisore o funzionario di una regione del Nord (Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)	Blocco Regionale I	Analisi macro-territoriale della propria area
Decisore o funzionario di una regione del Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria)	Blocco Regionale II	Analisi macro-territoriale della propria area
Decisore o funzionario di una regione del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria)	Blocco Regionale III (la Puglia è trattata a parte, nel Tomo I)	Analisi macro-territoriale della propria area
Decisore o funzionario di Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta	Blocco Regionale IV	Analisi macro-territoriale della propria area
Decisore o funzionario nazionale	Sezione Nazionale (capitolo introduttivo, sistemi sanitari regionali, telaio integrato)	Richiede il quadro d'insieme sull'estensione nazionale del modello
Chi cerca la sintesi per singola regione anziché per macro-area	Prima linea editoriale del Tomo II (Volumi 2–21)	Questo volume aggrega per macro-area, non fornisce un cruscotto per singola regione

Indice generale del Tomo II

Sezione Nazionale — Capitolo introduttivo dell'estensione nazionale · I sistemi sanitari regionali · L'Intelligenza Artificiale lungo il continuum assistenziale e la quantificazione del risparmio · La struttura della sperimentazione pilota · Gli atti per la consultazione

Blocco Regionale I — Italia settentrionale — Piemonte · Liguria · Lombardia · Trentino-Alto Adige · Veneto · Friuli-Venezia Giulia (parziale A–C) · Emilia-Romagna

Blocco Regionale II — Italia centrale — Toscana · Lazio · Marche · Umbria

Blocco Regionale III — Italia meridionale — Abruzzo · Molise · Campania · Basilicata · Calabria · Puglia
(*rinvio al Tomo I*)

Blocco Regionale IV — Isole e regioni residue — Sicilia · Sardegna · Valle d'Aosta

Quadro Conclusivo economico-sociale e multidisciplinare del Tomo II · Conclusione · Nota di rinvio bibliografico

Sezione Nazionale

Capitolo introduttivo dell'estensione nazionale

Estensione nazionale del modello Psicologo di Base potenziato dall'Intelligenza Artificiale

Indice

Estensione nazionale del modello “Psicologo di Base” potenziato dall'Intelligenza Artificiale

Capitolo introduttivo — Quadro dei Sistemi Sanitari Regionali, metodologia di trasferimento del modello pugliese e cornice di integrazione dell'Intelligenza Artificiale lungo il continuum diagnosi–prevenzione–trattamento–riabilitazione–recupero

0. Premessa: dal modello regionale al modello nazionale

Il presente documento avvia formalmente l'estensione su scala nazionale del progetto “Psicologo di Base”, finora elaborato e quantificato con riferimento alla sola Regione Puglia. L'impianto pugliese ha dimostrato, con metodologia evidence-based e attraverso una disaggregazione analitica dei costi diretti, dei risparmi diretti e dei risparmi indiretti, che l'inserimento strutturale di psicologi nelle cure primarie territoriali, in raccordo funzionale con i Centri di Salute Mentale, configura non un costo aggiuntivo insostenibile ma una ristrutturazione strategica del modello assistenziale dotata di ritorni economici e di salute robusti. Per la sola Puglia, a fronte di un organico a regime di 800–900 psicologi a tempo pieno equivalente e di un investimento annuo compreso tra 38,8 e 43,5 milioni di euro (fino a 41,7–46,7 milioni includendo un margine di contingenza del 7,5%), pari a un costo per abitante di soli 10–12 euro l'anno, sono stati stimati risparmi diretti sanitari nell'ordine di 250–330 milioni di euro l'anno a regime e risparmi indiretti compresi tra 330 e 540 milioni di euro l'anno, con un rapporto complessivo benefici/costi collocato in una forbice prudenziale di 6–12 a 1 su un orizzonte di 5–10 anni. L'integrazione sistematica di soluzioni di Intelligenza Artificiale nel medesimo modello, già oggetto di specifica trattazione, è stata stimata in grado di ridurre del 3–5% i costi diretti del servizio e di elevare il rapporto benefici/costi fino a valori di 10–15 a 1 negli scenari più favorevoli.

L'obiettivo di questa nuova fase è duplice e coerente con le indicazioni metodologiche del progetto. In primo luogo, si tratta di costruire la base dati sanitaria, demografica ed economica di ciascuna Regione e Provincia autonoma italiana, condizione necessaria per trasferire il modello pugliese ai restanti contesti territoriali, i quali presentano caratteristiche epidemiologiche, demografiche, organizzative e finanziarie significativamente differenti da quelle della Puglia. In secondo luogo, si tratta di sviluppare in profondità la dimensione dell'Intelligenza Artificiale, non più soltanto come leva di efficientamento gestionale del servizio, ma come tecnologia abilitante lungo l'intero continuum assistenziale — diagnosi, prevenzione, trattamento, riabilitazione e recupero — e come oggetto di un programma strutturato di formazione e accompagnamento di ogni medico di medicina generale e di ogni psicologo di base. La finalità ultima rimane la quantificazione dell'ulteriore riduzione della spesa sanitaria pubblica conseguibile, prima in Puglia e poi nell'intero Servizio Sanitario Nazionale, mediante l'adozione coordinata dell'Intelligenza Artificiale.

Il documento adotta un approccio rigorosamente evidence-based, multidisciplinare, multifattoriale e multidimensionale. Le fonti utilizzate comprendono le statistiche ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, le rilevazioni del Ministero della Salute, le elaborazioni della Fondazione GIMBE e della Corte dei Conti, i dati della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, le relazioni dell'OCSE e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché la letteratura scientifica peer-reviewed reperita attraverso la banca dati biomedica PubMed. Il tono è accademico e narrativo, privo di costruzioni metaforiche o figurative; i valori numerici sono espressi in cifre.

1. Cornice metodologica del trasferimento dal livello regionale al livello nazionale

1.1. Il principio del coefficiente pro capite calibrato

Il modello pugliese è stato costruito attorno a parametri pro capite, e questa caratteristica ne consente il trasferimento controllato agli altri contesti regionali. Il fabbisogno di organico psicologico è stato dimensionato in 800–900 unità a tempo pieno equivalente per una popolazione di 3.890.661 residenti, corrispondenti a un rapporto compreso tra 205,6 e 231,4 psicologi di base ogni milione di abitanti, ovvero tra 20,6 e 23,1 ogni 100.000 abitanti. Il costo unitario per psicologo a tempo pieno è stato fissato in circa 48.300–48.500 euro l'anno (oltre 52.000 euro includendo le contingenze), sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, della categoria D del profilo di psicologo non dirigente, con un moltiplicatore di costo pari a 1,426 rispetto allo stipendio tabellare lordo. I risparmi sono stati espressi come quote percentuali delle voci di spesa sanitaria aggredibili: visite di medicina generale improprie, prescrizioni farmacologiche inappropriate, accessi al Pronto Soccorso, ricoveri evitabili, prestazioni specialistiche e psichiatriche per quadri lievi-moderati gestibili in cure primarie, oltre alle componenti indirette relative a produttività persa, invalidità, oneri familiari e di caregiving.

Il trasferimento nazionale non può tuttavia consistere in una semplice moltiplicazione proporzionale della popolazione. Ciascuna Regione presenta una struttura per età differente, una diversa prevalenza di multimorbilità cronica, livelli eterogenei di spesa sanitaria pro capite, dotazioni di personale e di servizi territoriali non comparabili e profili economici che incidono sulla componente indiretta del risparmio. Per questa ragione il modello viene trasferito mediante un coefficiente pro capite calibrato su quattro fattori di aggiustamento regionale, di seguito descritti.

1.2. I quattro fattori di aggiustamento regionale

Il primo fattore è demografico e riguarda la quota di popolazione anziana e l'indice di vecchiaia, poiché la prevalenza dei disturbi mentali comuni — depressione, ansia, disturbi correlati allo stress — è più elevata nelle fasce di età avanzata, nei pazienti con pluripatologia e nelle condizioni di privazione socio-economica. Le Regioni con maggiore invecchiamento presentano un fabbisogno potenziale superiore e, simmetricamente, un potenziale di risparmio più ampio sulle voci farmaceutiche, specialistiche e di salute mentale legate alla cronicità.

Il secondo fattore è epidemiologico e organizzativo, e attiene al divario tra bisogno di salute mentale e offerta effettiva di servizi specialistici, misurabile attraverso i tassi di utenza dei Dipartimenti di Salute Mentale, la dotazione di psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale e gli accessi al Pronto Soccorso per cause psichiatriche. Dove l'offerta specialistica è più carente, lo psicologo di base interviene su un bacino di domanda inevasa più ampio, con un effetto di intercettazione precoce e di filtro clinico potenzialmente maggiore.

Il terzo fattore è finanziario e riguarda il livello di spesa sanitaria pubblica pro capite e lo stato dei conti regionali, con particolare riferimento alle Regioni sottoposte a piano di rientro. In tali contesti il vincolo di bilancio è più stringente, ma è anche più elevato il rendimento marginale di un intervento che riduce l'utilizzo inappropriato di risorse, poiché ogni euro risparmiato libera capacità in un sistema già in tensione.

Il quarto fattore è economico e attiene al prodotto interno lordo regionale e al tasso di occupazione, variabili che determinano l'entità della componente indiretta del risparmio, ossia la produttività recuperata, la riduzione delle assenze dal lavoro, il contenimento delle invalidità e dei pensionamenti anticipati per causa psichiatrica. Le Regioni a più elevato prodotto pro capite presentano un valore monetario della produttività persa più alto e, conseguentemente, un risparmio indiretto potenziale maggiore in termini assoluti.

1.3. La clusterizzazione delle Regioni

Per rendere operativo il trasferimento, le venti Regioni e le due Province autonome vengono aggregate in macro-aree omogenee — Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole — e in cluster funzionali definiti dalla combinazione dei quattro fattori di aggiustamento. Questa clusterizzazione consente di applicare a ciascun gruppo regionale coefficienti di calibrazione differenziati, evitando sia la sottostima del fabbisogno nei contesti ad alto invecchiamento e bassa offerta specialistica, sia la sovrastima dei risparmi nei contesti in cui la spesa di riferimento aggredibile è strutturalmente più contenuta. I capitoli successivi del progetto svilupperanno, Regione per Regione, la quantificazione puntuale dei costi di implementazione, dei risparmi diretti e indiretti, del ritorno sull'investimento e dei tempi di pareggio, applicando la medesima architettura analitica già validata per la Puglia.

2. Il quadro demografico nazionale e regionale

2.1. La popolazione residente e la sua distribuzione territoriale

Al 31 dicembre 2024, secondo i risultati del Censimento permanente diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica, la popolazione abitualmente dimorante in Italia ammonta a 58.943.464 individui, in lieve flessione rispetto agli anni precedenti. La componente straniera residente raggiunge 5.371.251 individui, pari al 9,1% del totale. La distribuzione territoriale della popolazione è fortemente concentrata: oltre un terzo dei residenti si addensa nelle tre Regioni più popolate. La Lombardia, con 10.033.918 abitanti, costituisce da sola circa il 17% della popolazione nazionale; seguono il Lazio con 5.709.178 residenti e la Campania con 5.582.337. Il quarto e il quinto posto sono occupati dal Veneto, con 4.853.472 abitanti, e dalla Sicilia, con 4.787.390. L'Emilia-Romagna conta 4.461.998 residenti e il Piemonte 4.251.868. La Puglia, contesto di riferimento del modello originario, si colloca all'ottavo posto con 3.877.395 abitanti, seguita dalla Toscana con 3.657.716.

Nella fascia intermedia si collocano la Calabria, con 1.834.646 residenti, la Sardegna, con 1.562.381, la Liguria, con 1.510.143, le Marche, con 1.480.545, l'Abruzzo, con 1.269.118, il Friuli-Venezia Giulia, con 1.193.284, e il Trentino-Alto Adige, con 1.086.252 abitanti complessivi ripartiti tra le due Province autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni meno popolate sono l'Umbria, con 851.473 residenti, la Basilicata, con 530.004, il Molise, con 287.814, e la Valle d'Aosta, con 122.532 abitanti. Questa marcata asimmetria dimensionale impone che il modello nazionale preveda soglie minime di servizio per le Regioni di piccole dimensioni, nelle quali l'organizzazione capillare per Casa della Comunità e per Nucleo di Cure Primarie deve essere modulata in funzione della densità abitativa e della dispersione territoriale, particolarmente accentuata nelle aree interne, montane e insulari.

2.2. L'invecchiamento della popolazione e la sua eterogeneità regionale

Il processo di invecchiamento costituisce il principale determinante strutturale del fabbisogno di salute mentale e, al tempo stesso, della spesa sanitaria aggredibile. A livello nazionale, la quota di popolazione di 65 anni e oltre si colloca attorno al 24,3–24,7% e l'indice di vecchiaia, che misura il numero di anziani ogni 100 giovani di 0–14 anni, è salito a 208 nel 2024, rispetto a 200 nel 2023 e a 149 nel 2011. La speranza di vita alla nascita ha ripreso a crescere, attestandosi a 83,4 anni, mentre la fecondità ha toccato il minimo storico di 1,18 figli per donna.

La distribuzione regionale dell'invecchiamento è marcatamente disomogenea e configura due Italie demografiche. All'estremo dell'invecchiamento si collocano la Liguria, regione più anziana del Paese con una quota di ultrasessantacinquenni del 29,2% e un indice di vecchiaia di 283, e la Sardegna, che condivide con la Liguria il valore più elevato dell'indice di vecchiaia, pari a 283, pur con una composizione per età parzialmente differente. Seguono, su livelli elevati, il Friuli-Venezia Giulia, con una quota di anziani del 27,1%, e l'Umbria, con il 27,0%. All'estremo opposto si collocano la Campania, regione più giovane con una quota di ultrasessantacinquenni del 20,9% e un indice di vecchiaia di 161, e il Trentino-Alto Adige, con il 22,1% di anziani e un indice di 162; la Sicilia presenta una quota di anziani del 23,2%. La Campania detiene anche la speranza di vita alla nascita più bassa, mentre le Province autonome di Bolzano e di Trento registrano i valori più elevati.

Questa eterogeneità ha implicazioni dirette per il trasferimento del modello. Le Regioni del Centro-Nord ad alto invecchiamento, quali Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, presentano un fabbisogno potenziale di psicologia di base proporzionalmente più elevato e un bacino di spesa cronica aggredibile più ampio, ma dispongono mediamente di sistemi sanitari più solidi e di una migliore dotazione di servizi. Le Regioni meridionali e insulari, pur più giovani in termini di struttura per età, scontano un divario di offerta più profondo e una più elevata incidenza di deprivazione socio-economica, fattore di rischio indipendente per i disturbi mentali comuni. La progettazione regionale dovrà pertanto bilanciare il peso demografico con il peso del divario di accesso.

2.3. Le proiezioni demografiche e la loro rilevanza per la sostenibilità

Le proiezioni dell'Istituto Nazionale di Statistica con base al 1° gennaio 2024 prefigurano, sull'orizzonte 2024–2050, una contrazione della popolazione nazionale e un ulteriore spostamento della struttura per età verso le classi anziane, con un incremento della quota di ultrasessantacinquenni che, a livello nazionale, tende verso valori prossimi o superiori a un terzo della popolazione entro il 2040–2050. Tale dinamica, già esplicitata nel modello pugliese attraverso l'ipotesi prudenziale di un incremento reale dell'1–1,5% annuo della spesa nelle componenti più sensibili, è destinata ad amplificare nel tempo sia il fabbisogno di salute mentale sia il potenziale di risparmio del servizio. Il calo demografico, concentrato nelle fasce giovanili, non riduce il bisogno assistenziale complessivo, poiché aumentano gli anziani e i pazienti con multimorbidità; l'immigrazione attenua la flessione ma introduce ulteriori fasce di utenza con bisogni specifici di salute mentale, legati a vulnerabilità psicosociali, traumi migratori e barriere linguistiche e culturali. La sostenibilità di lungo periodo del Servizio Sanitario Nazionale dipende dunque in misura crescente dalla capacità di intercettare precocemente il disagio psichico, obiettivo per il quale lo psicologo di base e le tecnologie di Intelligenza Artificiale costituiscono strumenti complementari.

3. La spesa sanitaria pubblica e i divari territoriali

3.1. Il quadro nazionale della spesa

Nel 2023, secondo il sistema dei conti della sanità dell'Istituto Nazionale di Statistica, la spesa sanitaria complessiva italiana è risultata pari a 176.153 milioni di euro, dei quali 130.291 milioni di spesa pubblica e 45.862 milioni di spesa privata; di quest'ultima, 40.641 milioni costituiscono spesa diretta delle famiglie e 5.221 milioni spesa intermediata da fondi e assicurazioni. In termini di composizione, il 74% della spesa è pubblica, il 23% è a carico diretto delle famiglie e il 3% è intermediata. Nel 2024 la spesa sanitaria complessiva ha raggiunto circa 185 miliardi di euro, con una quota privata in crescita che colloca l'Italia tra i valori più elevati nel confronto europeo. La Corte dei Conti, nella relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi sanitari regionali, ha rilevato l'aumento della spesa sanitaria pubblica da 131,3 a 138,3 miliardi nel triennio 2022–2024, con una crescita del 4,9% rispetto al 2023.

Il dato strutturalmente critico è il definanziamento relativo del sistema. Il rapporto tra spesa sanitaria pubblica e prodotto interno lordo è sceso al 6,2% nel 2023, minimo storico, risalendo al 6,3% nel 2024, valore che colloca l'Italia al di sotto della media dei Paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. La spesa sanitaria pubblica pro capite italiana, pari a circa 3.574 dollari nel 2023, rimane inferiore sia alla media dei Paesi dell'Organizzazione, pari a circa 4.174 dollari, sia alla media dei Paesi dell'Unione Europea, pari a circa 4.199 dollari. La Fondazione GIMBE ha quantificato il divario pro capite con la media dei Paesi dell'Unione Europea appartenenti all'Organizzazione in circa 889 dollari, corrispondente a un gap complessivo che sfiora i 52,4 miliardi di euro. Questo sottofinanziamento rende ancor più rilevante ogni intervento capace di liberare risorse attraverso la riduzione dell'inappropriatezza, quale è la psicologia di base.

3.2. La frattura strutturale Nord-Sud e i piani di rientro

La spesa sanitaria pro capite e, soprattutto, la qualità e l'esigibilità delle prestazioni si distribuiscono in modo profondamente diseguale lungo l'asse territoriale. Il Centro-Nord presenta livelli di spesa pro capite e di adempimento dei Livelli Essenziali di Assistenza generalmente superiori alla media nazionale, mentre il Mezzogiorno si colloca su valori inferiori. Nel 2022, secondo le elaborazioni richiamate dalla Fondazione GIMBE, soltanto 13 Regioni rispettavano gli standard essenziali di assistenza, con un ampliamento del divario Nord-Sud; tra le Regioni meridionali, soltanto Puglia e Basilicata risultavano adempienti, pur in posizioni di coda della graduatoria nazionale.

Sette Regioni risultano sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario: Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Puglia. In questi contesti il vincolo finanziario è più stringente e la capacità di investimento autonomo è limitata, circostanza che rende cruciale la dimostrazione del ritorno economico del modello e l'individuazione di meccanismi di finanziamento che non gravino esclusivamente sul bilancio sanitario regionale corrente. La frattura territoriale alimenta inoltre il fenomeno della migrazione sanitaria, con flussi di pazienti dalle Regioni meridionali verso quelle settentrionali, e la rinuncia alle cure: nel 2023 circa 4,5 milioni di cittadini, di cui 2,5 milioni per motivi economici, hanno rinunciato a prestazioni sanitarie, dato salito a 5,8 milioni nelle rilevazioni più recenti. La psicologia di base, in quanto servizio di prossimità a basso costo per abitante e ad alta accessibilità, agisce direttamente su entrambi i fenomeni, riducendo la necessità di spostamenti per prestazioni a bassa complessità e abbattendo le barriere economiche di accesso al supporto psicologico.

3.3. Implicazioni per la modellizzazione regionale della spesa aggredibile

Ai fini del trasferimento del modello, la spesa sanitaria pubblica regionale costituisce la base sulla quale calcolare le quote percentuali di risparmio. Poiché tale spesa si distribuisce in modo eterogeneo, e poiché le Regioni in piano di rientro presentano vincoli e, simmetricamente, margini di recupero specifici, la quantificazione regionale procederà associando a ciascun contesto la propria spesa sanitaria pubblica complessiva e la propria spesa per assistenza farmaceutica, specialistica, ospedaliera e di salute mentale, applicando a queste voci le percentuali di riduzione già validate per la Puglia, opportunamente calibrate sui quattro fattori di aggiustamento. Il principio prudenziale adottato nel modello originario — secondo cui soltanto una parte del potenziale di risparmio si traduce in riduzione effettiva di spesa, mentre l'altra parte rappresenta capacità assistenziale liberata e riqualificata — sarà mantenuto in tutte le elaborazioni regionali, a garanzia della credibilità delle stime presso gli interlocutori istituzionali.

4. I bisogni di salute mentale e l'offerta dei servizi

4.1. La dimensione epidemiologica del bisogno

La letteratura epidemiologica europea colloca la prevalenza nel corso della vita dei disturbi depressivi e d'ansia tra il 15% e il 20% della popolazione, con tassi annuali di disturbo mentale comune negli adulti compresi tra il 10% e il 15%. Applicando queste stime alla popolazione nazionale di 58.943.464 abitanti, si può stimare che ogni anno tra 5,9 e 8,8 milioni di adulti sperimentino un disturbo mentale comune meritevole di valutazione psicologica, e che una quota significativa di essi presenti quadri di gravità tale da richiedere un intervento psicologico o psicoterapeutico strutturato. L'impatto della pandemia ha amplificato il fenomeno: secondo le rilevazioni richiamate dalle società scientifiche, circa 16 milioni di italiani hanno sperimentato problemi di natura psicologica nel periodo successivo all'emergenza sanitaria, e quasi la metà degli adolescenti e dei giovani adulti tra i 18 e i 25 anni ha riferito sintomi di ansia e depressione. Il costo complessivo dei disturbi mentali per il Paese, considerando le componenti dirette e indirette, è stimato attorno al 4% del prodotto interno lordo.

4.2. L'offerta dei servizi specialistici e la sua insufficienza

A fronte di questo bisogno, l'offerta pubblica di servizi di salute mentale risulta strutturalmente sottodimensionata e finanziariamente penalizzata. Il Rapporto sulla Salute Mentale del Ministero della Salute relativo al 2023 documenta che le persone assistite dai servizi specialistici nel corso dell'anno sono state 854.040, esclusi i dati della Regione Abruzzo, con un tasso standardizzato nazionale di 169,5 utenti ogni 10.000 abitanti adulti. La variabilità regionale di tale tasso è amplissima e riflette differenze sia di domanda sia di capacità di presa in carico: si passa dal valore minimo di 108,5 delle Marche al massimo di 325,9 della Liguria. I pazienti entrati per la prima volta in contatto con i Dipartimenti di Salute Mentale nel 2023 sono stati 273.172. La composizione per età degli utenti riflette l'invecchiamento della popolazione generale, con il 67,3% dei pazienti al di sopra dei 45 anni.

Il dato più rilevante per il presente progetto è la quasi totale assenza, nel sistema pubblico, di una risposta strutturata ai disturbi mentali comuni di gravità lieve-moderata, che costituiscono la grande maggioranza del bisogno e che oggi ricadono impropriamente sugli studi di medicina generale, sul Pronto Soccorso o restano del tutto inevasi. Secondo il Collegio dei direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, circa 2 milioni di cittadini che dovrebbero essere seguiti dai servizi non lo sono. Gli accessi al Pronto Soccorso per disturbi psichiatrici nel 2023 sono stati 573.663, pari al 3,1% del totale degli accessi, dei quali il 13% ha esitato in ricovero; la quota più consistente, pari al 38,6%, ha riguardato sindromi nevrotiche e somatoformi, ossia proprio quei quadri che un servizio di psicologia di base intercetterebbe a monte. I ricoveri nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono stati 85.615, con 4.879 trattamenti sanitari obbligatori, pari al 5,7% del totale, e con una quota di riammissioni non programmate entro 30 giorni dalle dimissioni del 14,8%, indicatore di una continuità assistenziale territoriale insufficiente.

4.3. Il sottofinanziamento e la carenza di psicologi nel sistema pubblico

La spesa per la salute mentale in Italia si è attestata negli anni recenti attorno al 3% del Fondo Sanitario Nazionale, con un valore stimato in calo verso il 2,5% e una dotazione complessiva di poco superiore a 3,5 miliardi di euro, collocando il Paese tra gli ultimi in Europa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di destinare alla salute mentale almeno il 10% della spesa sanitaria; il Collegio dei direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale e le società scientifiche chiedono di raggiungere, in un triennio, almeno il 5% del Fondo Sanitario, con un incremento di oltre 2 miliardi di euro rispetto ai circa 4 miliardi attuali, accompagnato da un aumento del personale dedicato del 47,2%. La dotazione di psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale è particolarmente esigua: secondo il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, vi sono soltanto 3,8 psicologi ogni 100.000 abitanti nel sistema pubblico, a fronte di una media europea di 10 ogni 100.000. All'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, gli psicologi rappresentano appena il 6,9% del

personale, a fronte di una netta prevalenza del personale infermieristico. Questo divario di organico, quantificabile in un fattore di cinque-dieci volte rispetto agli standard internazionali avanzati, non è colmabile nel breve-medio periodo attraverso la semplice espansione dei servizi specialistici tradizionali, e costituisce il razionale strutturale per l'introduzione di una figura psicologica integrata nelle cure primarie.

4.4. Il pattern regionale del bisogno e dell'offerta

L'integrazione tra il dato epidemiologico e quello di servizio consente di delineare un pattern regionale utile alla calibrazione del modello. Nelle Regioni settentrionali ad alta intensità di servizio, quali Liguria ed Emilia-Romagna, il tasso di utenza specialistica è elevato e l'offerta è relativamente più strutturata, ma la pressione della cronicità e dell'invecchiamento mantiene ampio il bacino dei disturbi comuni gestibili in cure primarie; in tali contesti lo psicologo di base agisce prevalentemente come filtro che decongestiona i servizi specialistici e ne riqualifica la domanda. Nelle Regioni del Centro a forte invecchiamento, quali Umbria, Marche e Toscana, il modello interviene su un bisogno crescente in un sistema di media solidità. Nelle Regioni meridionali e insulari, dove l'offerta è più carente e la deprivazione socio-economica più diffusa, lo psicologo di base svolge una funzione primaria di intercettazione di una domanda largamente inevasa, con un potenziale di prevenzione della cronicizzazione e di riduzione degli accessi impropri particolarmente elevato. Tale differenziazione funzionale sarà incorporata nei coefficienti regionali di risparmio diretto e indiretto.

5. La medicina generale: organico, carenze e massimali

5.1. Il quadro nazionale della medicina generale

Il medico di medicina generale costituisce il principale punto di accesso al Servizio Sanitario Nazionale e il primo interlocutore del cittadino per il disagio psichico, ed è oggi in profonda crisi di sostenibilità. Secondo le elaborazioni della Fondazione GIMBE sui dati della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, al 1° gennaio 2025 i medici di medicina generale in Italia sono 36.812, in carico a oltre 50,9 milioni di assistiti, con una media di 1.383 assistiti per medico. Tra il 2019 e il 2024 il numero dei medici di medicina generale è diminuito di 5.197 unità, pari a una contrazione del 14,1%, passando da 42.009 a 36.812. La carenza complessiva, calcolata rispetto a un rapporto ottimale di un medico ogni 1.200 assistiti, è stimata in 5.716 medici e interessa 18 Regioni e Province autonome. Entro il 2028 sono previsti 8.180 pensionamenti, circostanza che aggraverà ulteriormente il quadro. La dotazione italiana, pari a circa 6,81 medici di medicina generale ogni 10.000 abitanti nel 2021, è significativamente inferiore a quella dei principali Paesi europei.

5.2. L'eterogeneità regionale del carico e della carenza

Anche la medicina generale presenta una marcata variabilità territoriale. Il numero medio di assistiti per medico oscilla dai 1.153 del Molise ai 1.533 della Lombardia, e le situazioni di carenza più critiche si registrano nelle grandi Regioni settentrionali, con la Lombardia che da sola presenta un deficit di circa 1.540 medici. La contrazione dell'organico nel periodo 2019–2024 è stata massima in Sardegna, con una riduzione del 40,3%, e minima nella Provincia autonoma di Trento, con un calo dell'1,5%, mentre la sola Provincia autonoma di Bolzano ha registrato un lieve incremento del 2,4%. Questa eterogeneità implica che il sollievo che lo psicologo di base può apportare alla medicina generale — assorbendo la quota di domanda psichica oggi impropriamente gestita negli studi, riducendo le prescrizioni farmacologiche inappropriate e contenendo gli invii non necessari ai servizi specialistici — assume valore differente da Regione a Regione, risultando massimo laddove il carico per medico è più elevato e la carenza più acuta. La sinergia operativa tra medico di medicina generale e psicologo di base, organizzata secondo la logica della coppia clinica all'interno delle Case della Comunità e dei Nuclei di Cure Primarie, costituisce pertanto un elemento di valore strutturale che si rafforza ulteriormente nei contesti di maggiore sofferenza dell'assistenza territoriale.

5.3. La cornice dell'assistenza territoriale e il raccordo con il modello

L'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale e gli investimenti della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata alla salute, hanno rafforzato l'integrazione dei medici convenzionati nelle Case della Comunità e nelle nuove strutture dell'assistenza territoriale, e hanno riorientato risorse verso l'assistenza domiciliare e la telemedicina. Questa cornice è favorevole all'inserimento dello psicologo di base, che può collocarsi naturalmente all'interno della rete delle Case della Comunità e dei Nuclei di Cure Primarie, operando in raccordo funzionale con i Centri di Salute Mentale secondo la logica dello stepped care e del collaborative care raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il modello nazionale farà leva su questa infrastruttura in via di realizzazione, evitando duplicazioni e massimizzando le sinergie con gli investimenti già programmati, in particolare quelli relativi alla telemedicina, che costituiscono il sostrato naturale per l'innesto delle soluzioni di Intelligenza Artificiale descritte nei capitoli successivi.

6. Le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale lungo il continuum assistenziale

L'Intelligenza Artificiale non costituisce, nel disegno del presente progetto, un fine in sé, bensì una tecnologia abilitante che potenzia la figura dello psicologo di base e del medico di medicina generale lungo l'intero continuum assistenziale: diagnosi, prevenzione, trattamento, riabilitazione e recupero. La letteratura scientifica più recente, reperita attraverso la banca dati biomedica PubMed, e le analisi economiche delle principali organizzazioni internazionali convergono nel documentare un potenziale rilevante di miglioramento dell'efficacia clinica e di riduzione dei costi unitari, a condizione che l'adozione sia governata, evidence-based e centrata sul paziente. Secondo le stime di settore richiamate dalla letteratura economica internazionale, l'adozione estesa dell'Intelligenza Artificiale potrebbe generare un risparmio compreso tra il 5% e il 10% della spesa sanitaria, prevalentemente attraverso l'automazione, il supporto alle decisioni cliniche e l'efficientamento operativo; le sole attività amministrative assorbono tra il 15% e il 25% della spesa sanitaria, e fino al 30% dei compiti di routine risulta automatizzabile. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rilevato che, in un contesto di invecchiamento, cronicità crescente e carenza di personale, l'Intelligenza Artificiale può alleviare la pressione sulla forza lavoro automatizzando i compiti amministrativi, ottimizzando l'allocazione delle risorse e supportando le decisioni cliniche, in particolare nelle Regioni sottoservite.

6.1. La diagnostica e la valutazione precoce

Nel dominio diagnostico, l'Intelligenza Artificiale supporta l'identificazione precoce dei disturbi mentali comuni e la stratificazione del rischio. Gli strumenti di triage e di valutazione iniziale basati su agenti conversazionali consentono di somministrare in modo standardizzato e accessibile screening per ansia, depressione e disagio correlato allo stress, di assegnare un livello di gravità e di orientare l'invio appropriato secondo la logica dello stepped care, riducendo il tempo clinico dedicato alle fasi di assessment ripetitive e liberando capacità per gli interventi a maggiore complessità. Una revisione sistematica della percezione e dei bisogni relativi all'Intelligenza Artificiale in sanità, pubblicata sul Journal of Medical Internet Research, ha documentato come l'uso dell'Intelligenza Artificiale sia percepito positivamente per la sua disponibilità, facilità d'uso e potenziale di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei costi del servizio, in particolare nelle cure primarie e comunitarie, nella gestione e auto-gestione delle patologie croniche, nella salute mentale e nelle procedure diagnostiche (Chew e Achananuparp, 2022; DOI: <https://doi.org/10.2196/32939>). Nel campo della diagnostica per immagini, gli algoritmi capaci di analizzare esami strumentali e di evidenziare aree di interesse consentono di sostituire test invasivi con accertamenti non invasivi, con effetti potenziali di contenimento dei costi, pur richiedendo attenzione al rischio di cascade di accertamenti indotte da reperti incidentali. La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato oltre 1.200 algoritmi medici basati su Intelligenza Artificiale alla data dell'agosto 2025, indicatore della maturità crescente del settore.

6.2. La prevenzione e la predizione

Nel dominio preventivo e predittivo, l'Intelligenza Artificiale consente di identificare in anticipo i soggetti a rischio attraverso l'analisi di dati clinici, comportamentali e contestuali, abilitando interventi proattivi prima che il disturbo si manifesti o si aggravi. L'analisi predittiva applicata alle popolazioni assistite permette di individuare i frequent attenders, i pazienti con multimorbidità a rischio di scompenso e gli adolescenti e i lavoratori a rischio di disagio, indirizzando verso di essi le risorse della psicologia di base in modo mirato. Le indagini sulla percezione pubblica degli interventi di salute mentale basati su Intelligenza Artificiale, pubblicate sul Journal of Medical Internet Research, evidenziano che tali strumenti sono considerati un'opzione valida per la prevenzione, per la valutazione primaria e per il mantenimento continuativo della salute mentale, con benefici principali in termini di accessibilità, economicità, disponibilità continua nelle ventiquattro ore e riduzione dello stigma, fattore quest'ultimo particolarmente rilevante per intercettare le fasce di popolazione che non si rivolgerebbero a un servizio tradizionale (Varghese, Sharma e Patwardhan, 2024; DOI: <https://doi.org/10.2196/64380>). La predizione e la prevenzione del peggioramento clinico contribuiscono inoltre a evitare l'evoluzione dei disturbi in disabilità permanente, mantenendo più persone attive e riducendo gli oneri previdenziali, con effetti diretti sulla componente indiretta del risparmio.

6.3. Il trattamento

Nel dominio del trattamento, l'Intelligenza Artificiale potenzia l'offerta terapeutica attraverso gli interventi psicologici digitali strutturati, in particolare la terapia cognitivo-comportamentale erogata via internet, che la letteratura colloca tra le componenti capaci di rendere i programmi di psicologia di base "dominanti" sotto il profilo costo-efficacia, ossia in grado di ottenere migliori esiti a costi inferiori rispetto all'assistenza usuale. Le evidenze meta-analitiche reperite attraverso PubMed sono solide. Una meta-analisi sulla terapia cognitivo-comportamentale erogata via internet per l'ansia ha documentato un effetto significativo e positivo, con una dimensione dell'effetto pari a circa 0,48 rispetto ai gruppi di controllo (Oliveira e colleghi, 2023; DOI: <https://doi.org/10.1016/j.invent.2023.100609>). Una meta-analisi con meta-regressione sugli interventi non assistiti ha rilevato dimensioni dell'effetto comprese tra 0,22 e 0,31 per la depressione e pari a 0,45 per l'ansia, mostrando inoltre che una progettazione persuasiva più curata si associa a una maggiore efficacia (McCall, Hadjistavropoulos e Sundström, 2021; DOI: <https://doi.org/10.2196/26939>). Una ulteriore meta-analisi ha documentato un effetto positivo sulla qualità della vita, con una dimensione complessiva pari a 0,35 e un effetto sul dominio della salute fisica pari a 0,56 (Maj e colleghi, 2023; DOI: <https://doi.org/10.1016/j.invent.2023.100654>). Gli agenti conversazionali terapeutici, secondo una revisione rapida pubblicata sul Journal of Medical Internet Research, svolgono ruoli di supporto al paziente, gestione della cura, educazione, costruzione di competenze e promozione di comportamenti salutaris, con benefici riconducibili al miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'assistenza e all'economicità dell'erogazione, pur con limiti di ordine etico, medico-legale, tecnico e di esperienza utente che ne richiedono un'integrazione governata (Laymouna e colleghi, 2024; DOI: <https://doi.org/10.2196/56930>). Questi strumenti consentono allo psicologo di base di estendere la propria capacità di presa in carico, riservando il tempo clinico in presenza ai casi a maggiore complessità e affidando alle componenti digitali, sotto supervisione, le fasi di mantenimento e di rinforzo terapeutico.

6.4. La riabilitazione e il recupero

Nel dominio della riabilitazione e del recupero, l'Intelligenza Artificiale supporta il monitoraggio continuo, l'adattamento personalizzato dei percorsi e il sostegno alla continuità assistenziale dopo la fase acuta, ambito in cui il sistema italiano mostra particolari fragilità, come testimoniato dalla quota del 14,8% di riammissioni non programmate entro 30 giorni dalle dimissioni dai Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura. Il monitoraggio remoto e gli assistenti virtuali consentono di seguire i pazienti nel proprio contesto di vita, di rilevare

precocemente i segnali di ricaduta e di sostenere l'aderenza ai piani terapeutici, riducendo i ricoveri ripetuti e la cronicizzazione. Tali tecnologie estendono inoltre il supporto ai caregiver familiari, alleggerendone il carico assistenziale e consentendo una migliore conciliazione tra cura e lavoro, con effetti positivi sul benessere del caregiver documentati dagli studi iniziali. La dimensione del recupero include altresì il reinserimento socio-lavorativo: gli strumenti digitali di automonitoraggio e di supporto psicologico ai lavoratori contribuiscono a ridurre le assenze e i cali di produttività e a favorire il ritorno al lavoro, con effetti che si riflettono direttamente sulla componente indiretta del risparmio.

6.5. L'efficientamento gestionale e amministrativo del servizio

Accanto alle applicazioni cliniche, l'Intelligenza Artificiale agisce sui costi diretti del servizio attraverso l'automazione dei compiti amministrativi e gestionali, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane e il miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi informativi. La documentazione clinica assistita, la trascrizione automatica multilingue, l'inserimento automatizzato dei dati, la pianificazione intelligente delle agende e la gestione ottimizzata degli invii consentono di liberare tempo professionale e di ridurre gli oneri di back-office. L'analisi già condotta per la Puglia ha stimato in 3–5% del budget diretto il risparmio conseguibile nel breve termine attraverso queste leve, pari a circa 1–2 milioni di euro l'anno a parità di offerta assistenziale, importi reinvestibili per ampliare il servizio o per coprire i costi tecnologici. A livello internazionale, numerosi sistemi sanitari hanno avviato meccanismi di rimborso e valutazione delle soluzioni digitali e di Intelligenza Artificiale, quali il percorso accelerato tedesco per le applicazioni digitali certificate, l'inclusione coreana dei dispositivi terapeutici digitali e diagnostici basati su Intelligenza Artificiale nella copertura assicurativa, il modello finlandese di valutazione delle tecnologie sanitarie digitali e il nuovo processo valutativo belga, a testimonianza di un orientamento regolatorio favorevole alla loro adozione strutturata.

7. La formazione del personale all'Intelligenza Artificiale: i quattro modelli

La capacità di realizzare i risparmi descritti dipende in misura decisiva dalle competenze del personale. La letteratura segnala che meno del 15% del corpo docente delle facoltà mediche ha ricevuto una formazione formale in Intelligenza Artificiale, e che la diffusione di curricula strutturati è ancora limitata. Il presente progetto adotta pertanto una strategia formativa articolata su quattro livelli complementari, che coprono l'intero arco della carriera professionale e che corrispondono alle quattro modalità individuate come opzioni di intervento: la formazione universitaria, la formazione post-universitaria, la formazione lavorativa continua e l'affiancamento di figure competenti in Intelligenza Artificiale presso ogni studio medico. I quattro livelli non sono alternativi bensì sequenziali e cumulativi, e configurano un sistema formativo capace di portare progressivamente l'intera forza lavoro della medicina generale e della psicologia di base a un livello di alfabetizzazione e di competenza operativa adeguato.

7.1. La formazione universitaria

Il primo livello riguarda l'inserimento dell'Intelligenza Artificiale nei percorsi di laurea in medicina e chirurgia e in psicologia, secondo l'approccio del curriculum a spirale integrato, che distribuisce le competenze lungo le fasi pre-cliniche, i tirocini clinici e gli insegnamenti elettivi, rinforzandole attraverso studi di caso e attività applicative. La letteratura internazionale ha sviluppato framework di competenze dedicati: una analisi consensuale di tipo Delphi ha individuato 23 competenze fondamentali per i medici che impiegano l'Intelligenza Artificiale nella pratica clinica, organizzate nelle dimensioni della conoscenza, delle abilità e degli atteggiamenti, mentre uno studio Delphi canadese, pubblicato su *npj Digital Medicine*, ha identificato 82 competenze essenziali e ne ha proposto l'integrazione nella biostatistica, nell'apprendimento basato su casi e nelle rotazioni cliniche. Una revisione di ambito (scoping review) pubblicata sul *Journal of Medical Internet Research – Medical Education* ha sintetizzato i framework e i programmi educativi in Intelligenza Artificiale

per studenti, specializzandi e medici in attività, evidenziando la necessità di una maggiore rilevanza clinica e personalizzazione e segnalando la scarsità di docenti qualificati come principale ostacolo (Tolentino e colleghi, 2024; DOI: <https://doi.org/10.2196/54793>). L'integrazione universitaria garantisce che le future generazioni di medici e psicologi entrino nel servizio già dotate delle competenze necessarie, riducendo nel tempo il fabbisogno di formazione di recupero.

7.2. La formazione post-universitaria

Il secondo livello riguarda i percorsi post-laurea, ossia le scuole di specializzazione, i corsi di formazione specifica in medicina generale, i master di secondo livello e i corsi di perfezionamento. In questa fase la formazione assume un carattere più applicativo e orientato al ruolo, distinto per professione: il medico di medicina generale sviluppa competenze nell'uso dei sistemi di supporto alle decisioni cliniche, nella valutazione critica degli output algoritmici e nell'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei percorsi di cura della cronicità; lo psicologo di base sviluppa competenze nell'impiego degli strumenti di screening e di triage digitale, nella conduzione e supervisione degli interventi psicologici erogati via internet e nella gestione del rapporto terapeutico mediato dalla tecnologia. La formazione post-universitaria deve inoltre affrontare in modo approfondito le dimensioni etiche, medico-legali e di sicurezza, comprese la riservatezza dei dati, la responsabilità professionale, il riconoscimento dei limiti e dei rischi degli strumenti e la capacità di mantenere il giudizio clinico autonomo anche in assenza di supporto algoritmico.

7.3. La formazione lavorativa continua

Il terzo livello riguarda la formazione continua nel contesto lavorativo, erogata attraverso il sistema dell'Educazione Continua in Medicina e attraverso percorsi aziendali strutturati. Questo livello è il più urgente, poiché interessa il personale già in servizio, che costituisce la massa critica chiamata a realizzare i risparmi nel breve e medio periodo. La formazione lavorativa deve essere modulare, progressiva e misurabile, deve prevedere attività pratiche con applicazione diretta agli strumenti adottati dal servizio e deve essere calibrata sui diversi livelli di partenza, particolarmente eterogenei in una forza lavoro nella quale, nella medicina generale, una quota maggioritaria di professionisti ha un'anzianità superiore ai 27 anni. Il modello pugliese ha già previsto un budget dedicato di 1.000.000 di euro l'anno per la formazione congiunta tra medici di medicina generale, psicologi e Centri di Salute Mentale, coerente con le migliori pratiche internazionali sul collaborative care; tale impostazione viene estesa al livello nazionale, integrando in modo specifico la componente di alfabetizzazione e competenza in Intelligenza Artificiale.

7.4. L'affiancamento di figure competenti in Intelligenza Artificiale

Il quarto livello riguarda l'affiancamento, presso ogni studio medico e ogni Casa della Comunità, di figure competenti in Intelligenza Artificiale, con funzione di supporto operativo, manutenzione, formazione sul campo e raccordo con i fornitori tecnologici. Questa figura, riconducibile ai nuovi ruoli professionali che l'OCSE segnala emergere nei sistemi che adottano strumenti digitali — quali i coordinatori di telemedicina e gli specialisti dell'implementazione — consente di superare il principale ostacolo all'adozione, ossia la distanza tra le competenze tecniche e i bisogni pratici del contesto clinico, e di assicurare che gli strumenti siano effettivamente utilizzati, correttamente configurati e costantemente aggiornati. L'affiancamento garantisce inoltre la continuità del supporto formativo, trasformando la formazione da evento puntuale a processo permanente integrato nel flusso di lavoro, e rappresenta la condizione organizzativa che permette di tradurre il potenziale teorico dell'Intelligenza Artificiale in risparmi effettivi e misurabili.

7.5. Le competenze da sviluppare e la loro misurazione

Trasversalmente ai quattro livelli, il sistema formativo deve sviluppare un insieme definito di competenze, sia tecniche sia non tecniche, che la letteratura riconduce alla comprensione dei concetti fondamentali dell'Intelligenza Artificiale, alla valutazione dell'accuratezza e dell'affidabilità degli strumenti, al riconoscimento delle conseguenze indesiderate e dei rischi, alla pratica etica e responsabile e all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale negli scenari clinici reali. Le organizzazioni internazionali, tra cui l'UNESCO, hanno proposto framework generali di competenza nell'Intelligenza Artificiale, che richiedono tuttavia un adattamento alle specificità delle professioni sanitarie. Il progetto adotta il principio della misurabilità delle competenze, prevedendo strumenti di valutazione psicometricamente robusti e un sistema di certificazione progressiva, condizione necessaria per rendere la formazione verificabile e per legare l'erogazione delle risorse al raggiungimento di obiettivi formativi definiti.

8. Quantificazione preliminare del risparmio aggiuntivo conseguibile

8.1. Il baseline nazionale del modello senza Intelligenza Artificiale

L'applicazione del coefficiente pro capite calibrato al livello nazionale consente una prima quantificazione di ordine di grandezza, da affinare nei capitoli regionali successivi. Sul piano dell'organico, il rapporto pugliese di 205,6–231,4 psicologi di base ogni milione di abitanti, applicato alla popolazione nazionale di 58.943.464 residenti, conduce a un fabbisogno complessivo compreso tra circa 12.100 e 13.600 psicologi a tempo pieno equivalente a regime. Sul piano dei costi, il parametro di 10–12 euro per abitante l'anno conduce a un investimento annuo nazionale a regime compreso tra circa 589 e 707 milioni di euro, ovvero tra circa 630 e 760 milioni includendo il margine di contingenza, pari a un valore dell'ordine di 0,6–0,76 miliardi di euro l'anno. Tale importo corrisponde a una frazione contenuta della spesa sanitaria pubblica nazionale, pari a circa lo 0,45–0,55% dei 138,3 miliardi di euro del 2024.

Sul piano dei risparmi, il trasferimento dei parametri pugliesi conduce, a regime, a risparmi diretti sanitari nazionali dell'ordine di 3,8–5,0 miliardi di euro l'anno e a risparmi indiretti dell'ordine di 5,0–8,2 miliardi di euro l'anno, per un beneficio complessivo lordo coerente con il rapporto benefici/costi prudenziale di 6–12 a 1 già stabilito per la Puglia. Mantenendo l'impostazione conservativa secondo cui soltanto una parte del potenziale si traduce in riduzione effettiva di spesa, mentre l'altra parte rappresenta capacità assistenziale liberata e riqualificata, il beneficio economico netto annuo del solo modello-base, su scala nazionale e a regime, si colloca in un intervallo ampio dell'ordine di alcuni miliardi di euro l'anno, con un profilo temporale crescente lungo la curva di implementazione e di apprendimento già descritta per la Puglia, articolata sugli orizzonti a 1, 3, 5 e 10 anni.

8.2. L'incremento di risparmio attribuibile all'Intelligenza Artificiale

L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale agisce su due piani distinti. Sul piano dei costi diretti del servizio, la riduzione del 3–5% del budget diretto, applicata all'investimento nazionale di 0,6–0,76 miliardi di euro, genera un risparmio dell'ordine di 18–38 milioni di euro l'anno, conseguibile a parità di offerta assistenziale attraverso l'automazione e l'efficientamento gestionale. Sul piano sistemico, più rilevante, l'Intelligenza Artificiale eleva l'efficacia clinica e la capacità di intercettazione precoce del servizio, traducendosi in un incremento dei risparmi diretti e indiretti che, secondo l'analisi già condotta per la Puglia, porta il rapporto benefici/costi da 6–12 a 1 fino a 10–15 a 1 negli scenari più favorevoli. Applicando questo incremento alla scala nazionale, il risparmio aggiuntivo annuo attribuibile specificamente all'Intelligenza Artificiale, al netto del modello-base e con criteri prudenziali, si colloca in un intervallo dell'ordine di 0,6–2,7 miliardi di euro l'anno a regime, riconducibile al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, alla riduzione degli accessi impropri al Pronto

Soccorso e dei ricoveri evitabili, al contenimento delle riammissioni e della cronicizzazione, e al recupero di produttività e alla riduzione delle invalidità. Questa stima preliminare, coerente con il potenziale del 5–10% di riduzione della spesa sanitaria documentato dalla letteratura economica internazionale per l'adozione estesa dell'Intelligenza Artificiale, sarà disaggregata e affinata Regione per Regione e voce per voce nei capitoli successivi.

8.3. L'aggiornamento del caso pugliese

Con riferimento specifico alla Puglia, l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale conferma e rafforza i risultati del modello-base. Al risparmio di 1–2 milioni di euro l'anno sui costi diretti del servizio si aggiunge l'incremento sistemico dei risparmi diretti e indiretti, con un effetto complessivo che, mantenendo i criteri prudenziali, eleva il beneficio netto regionale e accorcia i tempi di pareggio finanziario. La quantificazione puntuale dell'ulteriore riduzione della spesa sanitaria pugliese conseguibile mediante l'Intelligenza Artificiale, disaggregata per voce di spesa, per orizzonte temporale e per scenario di adozione, costituisce l'oggetto della trattazione di dettaglio già avviata e sarà ulteriormente consolidata in coerenza con l'architettura nazionale qui delineata.

9. La cornice regolatoria e la governance dell'adozione

L'adozione dell'Intelligenza Artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale deve avvenire entro una cornice regolatoria rigorosa, condizione di legittimità e di fiducia. Il quadro europeo è definito dal Regolamento sull'Intelligenza Artificiale, che classifica come ad alto rischio i sistemi destinati all'ambito sanitario e ne disciplina requisiti di trasparenza, sorveglianza umana, gestione del rischio e qualità dei dati, e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che prevede sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale per il trattamento non autorizzato dei dati personali. Lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari rafforza ulteriormente i meccanismi di tutela, comprese le sanzioni per i tentativi di re-identificazione dei dati anonimizzati. A livello nazionale si aggiungono la normativa italiana in materia di Intelligenza Artificiale e le strutture di governance del Servizio Sanitario Regionale.

La governance dell'adozione deve seguire le raccomandazioni che la letteratura individua come determinanti del successo: la prioritizzazione delle aree a maggiore impatto, la selezione di partner affidabili, la formazione e il coinvolgimento attivo del personale, la progressione per gradi con misurazione sistematica dei risultati e il mantenimento del paziente al centro del processo, secondo il principio per cui l'Intelligenza Artificiale è un mezzo e non un fine. La sostenibilità finanziaria dell'investimento tecnologico può essere garantita combinando risorse regionali, nazionali — tra cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Fondo Sanitario Nazionale — ed europee, e attraverso accordi intersettoriali che riconoscano il carattere trasversale dell'intervento, coinvolgendo nel co-finanziamento gli assessorati e gli enti che ne traggono beneficio in termini di minore disoccupazione, minori oneri assistenziali e maggiore produttività.

9-bis. Aggiornamento normativo: il Piano nazionale di azione per la Salute mentale 2025-2030 e la Legge di bilancio 2026

A integrazione e conferma della cornice regolatoria descritta al paragrafo precedente, occorre dare atto di uno sviluppo istituzionale sopravvenuto rispetto alle tranche precedenti di questo Tomo e di rilievo diretto per l'intera architettura dell'estensione nazionale qui delineata. Il 29 dicembre 2025 la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il nuovo Piano nazionale di azione per la Salute mentale (PANSM) 2025-2030, primo aggiornamento organico del documento di indirizzo nazionale dopo oltre un decennio dall'ultima revisione ([Ministero della Salute, comunicato stampa 29 dicembre 2025](#)). Il Piano individua nel rafforzamento del Dipartimento di salute mentale, integrato e inclusivo, e nel potenziamento dei servizi territoriali il proprio asse

portante, e prevede esplicitamente, tra le misure di attuazione, l'introduzione della figura dello psicologo di base quale presenza stabile e gratuita all'interno delle Case della Comunità e dei distretti territoriali, con funzione di primo livello di intervento per l'intercettazione precoce del disagio psichico, in piena coerenza con l'impianto concettuale e organizzativo sviluppato nel presente Tomo e nel Tomo I dedicato alla Regione Puglia ([Ministero della Salute; Regione Autonoma Valle d'Aosta, notizia 29 dicembre 2025](#)).

La Legge di bilancio 2026 ha attribuito copertura finanziaria dedicata a tale Piano, stanziando 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 e, a regime strutturale, 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 per le azioni di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza in materia di salute mentale; a queste risorse si affiancano ulteriori 30 milioni di euro annui destinati specificamente all'assunzione di personale sanitario e sociosanitario dedicato, con l'obiettivo dichiarato di garantire una presenza più capillare sul territorio ([Ministero della Salute, «Legge di bilancio 2026, le misure per la sanità», 2 gennaio 2026](#)). L'effettiva attuazione resta rimessa alla responsabilità delle singole amministrazioni regionali, alcune delle quali già dotate di un impianto organizzativo consolidato e altre destinate ad adeguarsi mediante nuovi modelli organizzativi nel corso del 2026 e degli anni successivi.

Questo sviluppo normativo non modifica in alcun modo l'impianto metodologico né i valori di rendimento adottati nel presente Tomo, ancorati in via esclusiva al duplice intervallo di Chisholm e collaboratori (2016): esso conferma, sul piano squisitamente istituzionale e con fonte autorevole e indipendente dagli obiettivi di questa ricerca, la fondatezza della traiettoria politico-legislativa qui anticipata e quantificata a livello regionale sin dal Tomo I. Il finanziamento nazionale dedicato, per quanto commisurato a una fase di avvio e non ancora equiparabile per ordine di grandezza agli investimenti stimati necessari a regime dal presente studio, rappresenta un primo riconoscimento tangibile, da parte del decisore pubblico centrale, della priorità strategica dell'integrazione della psicologia nelle cure primarie territoriali, e costituisce la base di partenza sulla quale le stime regionali qui sviluppate possono utilmente innestarsi in sede di programmazione attuativa.

A livello regionale, lo sviluppo più avanzato e documentato resta quello della Regione Toscana, la cui sperimentazione, avviata nel settembre 2024 in sette sedi ai sensi della legge regionale n. 39/2022 e del relativo regolamento attuativo (delibera n. 43/2024), è stata estesa nel marzo 2025 a ulteriori dieci sedi e successivamente prorogata per un ulteriore anno, a partire da marzo 2026, sull'insieme delle ventuno strutture nel frattempo coinvolte, con uno stanziamento regionale di 675.000 euro per il nuovo periodo di attività; la valutazione dell'andamento della sperimentazione, posta a fondamento della decisione di proroga, è stata giudicata positiva dalla Regione ([Giovanisi, Regione Toscana, «Prosegue per un altro anno la sperimentazione dello psicologo di base», 9 marzo 2026](#); [Toscana Medica, «La sperimentazione della Psicologia di base in Regione Toscana», settembre 2025](#)). Questo riscontro empirico, per quanto circoscritto nella scala e non direttamente comparabile in termini di rendimento economico con le stime del presente Tomo, costituisce un primo elemento di validazione operativa del modello organizzativo — accesso su invio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, collocazione presso le Case della Comunità, integrazione funzionale con la medicina generale — che il presente studio adotta come riferimento strutturale per l'intero territorio nazionale.

10. Roadmap dei capitoli successivi dell'estensione nazionale

Il presente capitolo introduttivo costituisce la base metodologica e documentale dell'estensione nazionale e definisce l'architettura entro la quale si svilupperanno i capitoli successivi, secondo il medesimo metodo sequenziale di approvazione per fasi già adottato per la Puglia. La sequenza prevista è la seguente. Un capitolo dedicato all'analisi disaggregata, Regione per Regione, della spesa sanitaria pubblica complessiva e delle sue componenti farmaceutica, specialistica, ospedaliera e di salute mentale, con la ricostruzione della spesa aggredibile. Un capitolo sul dimensionamento regionale dell'organico di psicologia di base e sui costi diretti di implementazione, calibrati sui quattro fattori di aggiustamento. Un capitolo sui risparmi diretti regionali,

articolato per voce di spesa e per orizzonte temporale. Un capitolo sui risparmi indiretti regionali, comprensivo della produttività, delle invalidità, degli oneri familiari e di caregiving. Un capitolo sull'integrazione dell'Intelligenza Artificiale a livello regionale, con la quantificazione puntuale dell'ulteriore risparmio per ciascuna delle cinque dimensioni del continuum assistenziale. Un capitolo sul programma formativo nazionale articolato sui quattro livelli, con i relativi costi e i tempi di attuazione. Un capitolo sul saldo economico complessivo, sulla sostenibilità finanziaria e sulle coperture a livello nazionale, con l'aggregazione dei risultati regionali, l'analisi di sensibilità e la valutazione del ritorno sull'investimento e dei tempi di pareggio.

L'insieme di questi capitoli costituirà il dossier tecnico-finanziario nazionale del progetto "Psicologo di Base" potenziato dall'Intelligenza Artificiale, destinato a fornire agli interlocutori istituzionali regionali e nazionali una base quantitativa robusta, trasparente, evidence-based e verificabile, in grado di dimostrare che l'integrazione della psicologia nelle cure primarie e l'adozione coordinata dell'Intelligenza Artificiale non costituiscono un costo aggiuntivo insostenibile, bensì una ristrutturazione strategica del modello assistenziale orientata alla sostenibilità di lungo periodo, all'appropriatezza clinica, all'equità di accesso e alla riduzione strutturale della spesa sanitaria pubblica.

11. Nota sulle fonti e attribuzione

Le statistiche demografiche, economiche e sanitarie qui riportate derivano da fonti ufficiali e istituzionali, tra cui l'Istituto Nazionale di Statistica (Censimento permanente della popolazione, anno 2024, e proiezioni demografiche con base 1° gennaio 2024), il Ministero della Salute (Rapporto sulla Salute Mentale, anno 2023), la Corte dei Conti (relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi sanitari regionali), la Fondazione GIMBE (rapporti e osservatori sul Servizio Sanitario Nazionale e stime sulla carenza dei medici di medicina generale al 1° gennaio 2025), la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le evidenze scientifiche relative all'efficacia clinica e al rapporto costo-efficacia dell'Intelligenza Artificiale e degli interventi psicologici digitali sono tratte da articoli peer-reviewed reperiti attraverso la banca dati biomedica PubMed. In particolare, si richiamano: Chew H.S.J., Achananuparp P., "Perceptions and Needs of Artificial Intelligence in Health Care to Increase Adoption: Scoping Review", *Journal of Medical Internet Research*, 2022 (DOI: <https://doi.org/10.2196/32939>); Laymouna M. e colleghi, "Roles, Users, Benefits, and Limitations of Chatbots in Health Care: Rapid Review", *Journal of Medical Internet Research*, 2024 (DOI: <https://doi.org/10.2196/56930>); Varghese M.A., Sharma P., Patwardhan M., "Public Perception on Artificial Intelligence-Driven Mental Health Interventions: Survey Research", *JMIR Formative Research*, 2024 (DOI: <https://doi.org/10.2196/64380>); Oliveira C. e colleghi, "Internet-delivered cognitive behavioral therapy for anxiety among university students: A systematic review and meta-analysis", *Internet Interventions*, 2023 (DOI: <https://doi.org/10.1016/j.invent.2023.100609>); McCall H.C., Hadjistavropoulos H.D., Sundström C.R.F., "Exploring the Role of Persuasive Design in Unguided Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy for Depression and Anxiety Among Adults: Systematic Review, Meta-analysis, and Meta-regression", *Journal of Medical Internet Research*, 2021 (DOI: <https://doi.org/10.2196/26939>); Maj A. e colleghi, "The effect of internet-delivered cognitive behavioral therapy for depression and anxiety on quality of life: A meta-analysis of randomized controlled trials", *Internet Interventions*, 2023 (DOI: <https://doi.org/10.1016/j.invent.2023.100654>); Tolentino R. e colleghi, "Curriculum Frameworks and Educational Programs in AI for Medical Students, Residents, and Practicing Physicians: Scoping Review", *JMIR Medical Education*, 2024 (DOI: <https://doi.org/10.2196/54793>). Le stime economiche sull'impatto dell'Intelligenza Artificiale in sanità derivano da analisi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e da studi di settore richiamati dalla letteratura economica internazionale. I parametri del modello-base e dell'integrazione dell'Intelligenza Artificiale relativi alla Regione Puglia sono tratti dai capitoli del progetto già elaborati.

I sistemi sanitari regionali

Estensione Nazionale del Modello Psicologo di Base  Capitolo 1: Quadro Comparativo dei Sistemi Sanitari Regionali

Indice

Estensione nazionale del modello “Psicologo di Base” potenziato dall’Intelligenza Artificiale

Capitolo 1 (livello nazionale) — Quadro comparativo dei Sistemi Sanitari Regionali, bisogni di salute mentale e spesa sanitaria aggredibile

Premessa metodologica e oggetto del capitolo

Il presente capitolo costituisce la base dati comparativa dell’estensione nazionale del progetto “Psicologo di Base”, e risponde alla prima e fondamentale esigenza metodologica del trasferimento del modello pugliese all’intero Servizio Sanitario Nazionale: disporre, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, dei dati demografici, epidemiologici, organizzativi e finanziari necessari ad applicare l’architettura analitica già validata per la Puglia. Il capitolo procede attraverso un approccio rigorosamente evidence-based, multidisciplinare, multifattoriale e multidimensionale, integrando epidemiologia descrittiva, demografia, economia sanitaria, sociologia della salute e analisi comparativa dei sistemi sanitari regionali, sulla base di dati certificati dall’Istituto Nazionale di Statistica, dal Ministero della Salute, dalla Corte dei Conti, dalla Fondazione GIMBE, dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale dell’Università Bocconi.

Il modello pugliese ha dimostrato, con metodologia trasparente e prudentiale, che l’inserimento strutturale di 800–900 psicologi a tempo pieno equivalente nelle cure primarie regionali, in raccordo funzionale con i Centri di Salute Mentale, comporta un investimento annuo compreso tra 38,8 e 43,5 milioni di euro nello scenario standard ed espansivo, fino a 41,7–46,7 milioni includendo un margine di contingenza del 7,5%, pari a un costo per abitante di soli 10–12 euro l’anno e a un costo medio per psicologo a tempo pieno di 48.300–48.500 euro l’anno comprensivo di tutti gli oneri riflessi, della formazione, della supervisione, della governance, dei sistemi informativi e delle infrastrutture. A fronte di questo investimento, il modello genera risparmi diretti sanitari e risparmi indiretti socioeconomici quantificati nei capitoli successivi della relazione pugliese, con rapporti benefici/costi ampiamente favorevoli. L’obiettivo dell’estensione nazionale è replicare questa quantificazione per ogni Regione, tenendo conto delle profonde differenze demografiche, epidemiologiche, organizzative e finanziarie che caratterizzano i ventuno sistemi sanitari regionali italiani.

Una nota preliminare di raccordo è necessaria. Il dossier pugliese contiene due ordini di stima dei costi: una formulazione iniziale, contenuta nel Capitolo 1, che colloca l’investimento attorno a 60 milioni di euro annui per 800 psicologi e a 67,5 milioni per 900, basata su un costo unitario lordo comprensivo più ampio; e una formulazione analitica e prudentiale, contenuta nel Capitolo 4, che dettaglia ogni voce di spesa e quantifica l’investimento in 38,8–43,5 milioni di euro annui, con un costo per abitante di 10–12 euro. L’estensione nazionale adotta come base di calcolo la formulazione analitica del Capitolo 4, in quanto disaggregata, verificabile e prudentiale, segnalando tuttavia che la stima superiore del Capitolo 1 può essere utilizzata come limite massimo dell’intervallo nelle proiezioni di sensibilità. Tutti i valori sono espressi in cifre e a prezzi costanti.

1. Il quadro nazionale di sintesi

1.1. La popolazione e la sua distribuzione

Al 31 dicembre 2024, secondo i risultati del Censimento permanente dell'Istituto Nazionale di Statistica, la popolazione abitualmente dimorante in Italia ammonta a 58.943.464 individui, dei quali 5.371.251 stranieri, pari al 9,1% del totale. La distribuzione è fortemente concentrata e asimmetrica: la Lombardia, con 10.033.918 abitanti, raccoglie circa il 17% della popolazione nazionale; le prime tre Regioni — Lombardia, Lazio con 5.709.178 e Campania con 5.582.337 — superano insieme un terzo del totale; le ultime quattro — Umbria con 851.473, Basilicata con 530.004, Molise con 287.814 e Valle d'Aosta con 122.532 — non raggiungono complessivamente il 3,1% della popolazione. Questa asimmetria impone che il modello nazionale preveda soglie minime di servizio per le Regioni di piccole dimensioni e una modulazione dell'organizzazione capillare in funzione della densità abitativa e della dispersione territoriale.

1.2. La spesa sanitaria pubblica e i divari di qualità

Nel 2023, secondo il sistema dei conti della sanità dell'Istituto Nazionale di Statistica, la spesa sanitaria complessiva è risultata pari a 176.153 milioni di euro, dei quali 130.291 milioni di spesa pubblica, pari al 74% del totale. La Corte dei Conti ha rilevato la crescita della spesa pubblica fino a 138,3 miliardi nel 2024. Un dato cruciale ai fini del trasferimento del modello riguarda la distribuzione territoriale della spesa pubblica pro capite: a differenza di quanto si potrebbe presumere, tale spesa è relativamente uniforme tra le Regioni, per effetto dei meccanismi di perequazione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Nel 2022 la spesa sanitaria pubblica pro capite si è collocata su una media nazionale di circa 2.197 euro, con un intervallo compreso tra i 2.028 euro della Calabria e i 2.770 euro della Provincia autonoma di Bolzano, e con la Campania a 2.051 euro. L'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul prodotto interno lordo regionale varia invece ampiamente, dal 5,1% della Lombardia e di Bolzano fino a oltre l'11% in Calabria, riflettendo la diversa ricchezza dei territori più che la diversa generosità del finanziamento sanitario.

La divergenza territoriale si manifesta dunque non tanto nel volume pro capite della spesa pubblica, quanto nella qualità, nell'appropriatezza e nell'esigibilità delle prestazioni. Nel 2022 soltanto 13 Regioni rispettavano gli standard essenziali di assistenza, con un ampliamento del divario tra Nord e Sud; tra le Regioni meridionali soltanto Puglia e Basilicata risultavano adempienti, pur in posizioni di coda. Sette Regioni risultano sottoposte al piano di rientro dal disavanzo sanitario: Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Puglia. Speculare alla qualità della sanità pubblica è la spesa sanitaria privata diretta delle famiglie, che misura indirettamente le barriere di accesso: nel 2023 la media nazionale è stata di circa 730 euro pro capite, con un intervallo amplissimo che va dai 377 euro della Basilicata ai 1.032 euro della Lombardia, riflettendo la minore capacità di spesa e la rinuncia alle cure nelle Regioni meridionali, dove i cittadini più spesso non possono permettersi di compensare privatamente le carenze del servizio pubblico. Questa lettura combinata — spesa pubblica pro capite quasi uniforme, ma qualità e spesa privata fortemente divergenti — è il fondamento metodologico per la calibrazione regionale dei coefficienti di risparmio.

1.3. Il bisogno di salute mentale e la carenza dell'offerta

A livello nazionale, la prevalenza annuale dei disturbi mentali comuni negli adulti è collocata dalla letteratura epidemiologica tra il 10% e il 15%, con una prevalenza nel corso della vita di disturbi depressivi e d'ansia tra il 15% e il 20%; l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il 20–30% della popolazione sperimenti qualche forma di disagio psicologico clinicamente significativo nell'arco di un anno. Applicando queste stime alla popolazione nazionale, si può stimare che ogni anno tra 5,9 e 8,8 milioni di adulti sperimentino un disturbo mentale comune meritevole di valutazione psicologica. A fronte di questo bisogno, l'offerta pubblica è strutturalmente sottodimensionata: la spesa per la salute mentale si attesta attorno al 3% del Fondo Sanitario

Nazionale, in calo verso il 2,5%, contro il 10% raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; la dotazione di psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale è di 3,8 ogni 100.000 abitanti, contro una media europea di 10 ogni 100.000. Nel 2023 le persone assistite dai servizi specialistici di salute mentale sono state 854.040, esclusi i dati dell'Abruzzo, con un tasso standardizzato nazionale di 169,5 ogni 10.000 abitanti adulti e con una variabilità regionale amplissima, dal minimo di 108,5 delle Marche al massimo di 325,9 della Liguria; gli accessi al Pronto Soccorso per cause psichiatriche sono stati 573.663, pari al 3,1% del totale. Il modello pugliese costituisce il riferimento metodologico per la lettura regionale di questi dati: in Puglia operano 170 psicologi nei Dipartimenti di Salute Mentale, pari a 4,4 ogni 100.000 abitanti, e la spesa per l'assistenza psichiatrica ammonta a circa 285 milioni di euro, pari al 3,3% della spesa sanitaria pubblica regionale di circa 8,55 miliardi di euro.

1.4. La medicina generale

Al 1° gennaio 2025 i medici di medicina generale in Italia sono 36.812, in carico a oltre 50,9 milioni di assistiti, con una media di 1.383 assistiti per medico, in forte calo rispetto ai 42.009 del 2019. La carenza, calcolata rispetto al rapporto ottimale di un medico ogni 1.200 assistiti, è stimata in 5.716 unità e interessa 18 Regioni; entro il 2028 sono previsti 8.180 pensionamenti. Il carico medio per medico varia dai 1.153 assistiti del Molise ai 1.533 della Lombardia, e la contrazione dell'organico tra il 2019 e il 2024 è stata massima in Sardegna, con una riduzione del 40,3%, e minima nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Questo quadro definisce, Regione per Regione, l'entità del sollievo che lo psicologo di base può apportare alla medicina generale, assorbendo la domanda psichica oggi impropriamente gestita negli studi e contenendo le prescrizioni e gli invii inappropriati.

1.5. Il gradiente socioeconomico

Il quarto fattore di calibrazione, di natura economica, attiene alla vulnerabilità socioeconomica, determinante indipendente dei disturbi mentali e base della componente indiretta del risparmio. Nel 2024 il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno, pari all'11,9%, ha superato di oltre tre volte quello del Nord-Est, pari al 3,6%; la Campania ha registrato il valore più elevato, 15,6%, e la Provincia autonoma di Bolzano il più basso, 2,0%; il tasso di disoccupazione giovanile nazionale è stato del 20,3%, con un picco del 42,6% in Calabria. La condizione di giovani non occupati né in istruzione o formazione ha riguardato il 15,2% della popolazione giovanile a livello nazionale, con valori molto più elevati nel Mezzogiorno. L'indicatore di rischio di povertà o esclusione sociale ha interessato il 23,1% della popolazione nazionale, salendo al 39,8% nel Sud e al 38,1% nelle Isole. Questo gradiente, fortemente sfavorevole al Mezzogiorno, implica che il risparmio indiretto del modello — produttività recuperata, minori invalidità, minori oneri familiari — assume valore monetario differente da Regione a Regione, risultando più elevato in termini assoluti nelle Regioni a più alto prodotto e più elevato in termini di prevenzione del rischio nelle Regioni a maggiore deprivazione.

2. Il quadro per macro-aree e Regioni

L'estensione del modello procede aggregando le Regioni in cinque macro-aree omogenee — Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole — entro le quali si collocano i profili regionali specifici. Per ciascuna Regione viene indicato il fabbisogno potenziale di organico psicologico calcolato applicando il coefficiente standard del modello pugliese, pari a circa 20,5–23,1 psicologi a tempo pieno equivalente ogni 100.000 abitanti, ovvero 205,6–231,4 ogni milione, da intendersi come riferimento da calibrare successivamente sui quattro fattori di aggiustamento.

2.1. Nord-Ovest

Il Nord-Ovest comprende la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, e si caratterizza per sistemi sanitari solidi, elevata capacità di spesa privata e, in alcune sue componenti, per un invecchiamento particolarmente accentuato.

La Lombardia, con 10.033.918 abitanti, è la Regione più popolosa e, in valore assoluto, quella che presenta il maggiore fabbisogno: applicando il coefficiente standard si stima un organico compreso tra circa 2.057 e 2.318 psicologi di base a tempo pieno equivalente. La Lombardia presenta la più bassa incidenza della spesa sanitaria pubblica sul prodotto, pari al 5,1%, riflesso della sua ricchezza, e la più elevata spesa sanitaria privata pro capite del Paese, pari a circa 1.032 euro, indicatore di un'ampia capacità delle famiglie di rivolgersi al mercato. È inoltre la Regione con la più grave carenza assoluta di medici di medicina generale, stimata in circa 1.540 unità, e con il più elevato carico medio per medico, pari a 1.533 assistiti. Questa combinazione configura un contesto in cui lo psicologo di base agisce prevalentemente come filtro che decongestiona una medicina generale sovraccarica e come strumento di contenimento di una spesa privata elevata, intercettando una domanda che oggi si rivolge in larga misura al settore privato.

Il Piemonte, con 4.251.868 abitanti, presenta un fabbisogno stimato tra circa 872 e 984 psicologi, un tasso di disoccupazione del 5,4%, il più elevato tra le Regioni settentrionali, e un profilo demografico in invecchiamento. La Liguria, con 1.510.143 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 310 e 349 psicologi, è la Regione più anziana d'Italia, con una quota di ultrasessantacinquenni del 29,2% e un indice di vecchiaia di 283, e registra il più elevato tasso di utenza dei servizi di salute mentale del Paese, pari a 325,9 ogni 10.000 abitanti, indicatore di una domanda specialistica molto intensa che lascia ampio spazio a un'azione di filtro e di presa in carico dei disturbi comuni a livello di cure primarie. La Valle d'Aosta, con 122.532 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 25 e 28 psicologi, costituisce il caso paradigmatico della Regione di piccole dimensioni, nella quale il modello deve prevedere una soglia minima di servizio e una forte componente di telepsicologia e di équipe mobile per garantire la copertura di un territorio montano e disperso.

2.2. Nord-Est

Il Nord-Est comprende il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige con le due Province autonome di Trento e di Bolzano, e si caratterizza per i migliori indicatori socioeconomici e per sistemi sanitari tra i più performanti del Paese.

Il Veneto, con 4.853.472 abitanti, presenta un fabbisogno stimato tra circa 995 e 1.123 psicologi, e un mercato del lavoro solido, con un tasso di disoccupazione del Nord-Est che si attesta al 3,6%. L'Emilia-Romagna, con 4.461.998 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 915 e 1.033 psicologi, è tra le Regioni con i migliori livelli di adempimento degli standard essenziali di assistenza e con una elevata spesa sanitaria privata pro capite, pari a circa 861 euro, segno di un sistema in cui la componente integrativa è strutturata. Il Friuli-Venezia Giulia, con 1.193.284 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 245 e 276 psicologi, è la seconda Regione più anziana d'Italia, con una quota di ultrasessantacinquenni del 27,1%, e presenta dunque un bacino di cronicità e di comorbilità psico-somatica particolarmente ampio. Il Trentino-Alto Adige, con 1.086.252 abitanti complessivi e un fabbisogno stimato tra circa 223 e 251 psicologi, costituisce un caso peculiare: la Provincia autonoma di Bolzano presenta la più elevata spesa sanitaria pubblica pro capite del Paese, pari a 2.770 euro, la più bassa disoccupazione, pari al 2,0%, la più alta speranza di vita e l'unica dinamica positiva dell'organico della medicina generale, mentre la Provincia autonoma di Trento condivide profili di eccellenza analoghi; la programmazione dovrà tenere conto dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle due Province.

2.3. Centro

Il Centro comprende il Lazio, la Toscana, le Marche e l'Umbria, e presenta una situazione intermedia, con un forte invecchiamento e sistemi sanitari di media-elevata solidità, fatta eccezione per il Lazio, sottoposto a piano di rientro.

Il Lazio, con 5.709.178 abitanti, presenta un fabbisogno stimato tra circa 1.170 e 1.321 psicologi, è sottoposto a piano di rientro dal disavanzo sanitario e registra una delle più elevate spese sanitarie private pro capite e dei più alti livelli di rinuncia alle cure, riflesso di tempi di attesa elevati che spingono i cittadini verso il mercato; in tale contesto il modello agisce simultaneamente sull'appropriatezza pubblica e sulla riduzione della spesa privata indotta dalle liste di attesa. La Toscana, con 3.657.716 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 750 e 846 psicologi, presenta il più basso tasso di disoccupazione del Centro, pari al 4,0%, e un sistema sanitario tra i più solidi del Paese. Le Marche, con 1.480.545 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 304 e 343 psicologi, registrano il più basso tasso di utenza dei servizi di salute mentale del Paese, pari a 108,5 ogni 10.000 abitanti, dato che, a fronte di un bisogno epidemiologico non inferiore, segnala una intercettazione specialistica particolarmente bassa e dunque un ampio bacino di domanda inevasa che lo psicologo di base potrebbe intercettare. L'Umbria, con 851.473 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 175 e 197 psicologi, è la terza Regione più anziana d'Italia, con una quota di ultrasessantacinquenni del 27,0%, con le implicazioni già descritte in termini di cronicità e comorbidità.

2.4. Sud

Il Sud comprende la Campania, la Puglia, la Calabria, l'Abruzzo, il Molise e la Basilicata, e costituisce, insieme alle Isole, l'area in cui il divario tra bisogno e offerta è più profondo, la deprivazione socioeconomica più diffusa e i vincoli di bilancio più stringenti, ma anche quella in cui il rendimento marginale del modello, in termini di prevenzione della cronicizzazione, riduzione degli accessi impropri e contenimento della migrazione sanitaria, è potenzialmente più elevato.

La Campania, con 5.582.337 abitanti, presenta il maggiore fabbisogno dell'area, stimato tra circa 1.144 e 1.292 psicologi, ed è sottoposta a piano di rientro; pur essendo la Regione demograficamente più giovane, con una quota di ultrasessantacinquenni del 20,9% e un indice di vecchiaia di 161, registra il più elevato tasso di disoccupazione del Paese, pari al 15,6%, la più bassa speranza di vita e livelli di rischio di povertà o esclusione sociale tra i più alti d'Italia, configurando un substrato di vulnerabilità psicosociale che amplifica il bisogno di salute mentale e il potenziale di risparmio indiretto. La Puglia, con 3.877.395 abitanti, costituisce il caso di riferimento del modello, con un fabbisogno standard di circa 795–897 psicologi, già oggetto della quantificazione completa nei capitoli pugliesi. La Calabria, con 1.834.646 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 376 e 425 psicologi, è sottoposta a piano di rientro, presenta la più bassa spesa sanitaria pubblica pro capite del Paese, pari a 2.028 euro, la più alta incidenza della spesa sanitaria sul prodotto regionale, oltre l'11%, e il più elevato tasso di disoccupazione giovanile, pari al 42,6%, configurando il contesto di maggiore fragilità combinata del Paese. L'Abruzzo, con 1.269.118 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 260 e 294 psicologi, e il Molise, con 287.814 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 59 e 67 psicologi, sono entrambi sottoposti a piano di rientro; il Molise presenta il più basso carico medio per medico di medicina generale del Paese, pari a 1.153 assistiti, e costituisce, insieme alla Valle d'Aosta, il caso della Regione di piccolissime dimensioni che richiede soglie minime di servizio e forte ricorso alla telepsicologia. La Basilicata, con 530.004 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 109 e 123 psicologi, pur appartenendo al Mezzogiorno presenta il più basso tasso di disoccupazione dell'area, pari al 6,7%, e la più bassa spesa sanitaria privata pro capite del Paese, pari a 377 euro, indicatore al tempo stesso di minori barriere relative e di una capacità di spesa privata strutturalmente contenuta.

2.5. Isole

Le Isole comprendono la Sicilia e la Sardegna, accomunate dalla condizione di insularità, che amplifica le barriere geografiche di accesso e la rilevanza della telepsicologia e delle équipe mobili.

La Sicilia, con 4.787.390 abitanti, presenta un fabbisogno stimato tra circa 981 e 1.108 psicologi, è sottoposta a piano di rientro e condivide con le altre Regioni meridionali livelli elevati di disoccupazione, di condizione giovanile inattiva e di rischio di povertà o esclusione sociale, con un indicatore di area pari al 38,1% nelle Isole. La Sardegna, con 1.562.381 abitanti e un fabbisogno stimato tra circa 320 e 362 psicologi, condivide con la Liguria il più elevato indice di vecchiaia del Paese, pari a 283, e ha registrato la più marcata contrazione dell'organico della medicina generale tra il 2019 e il 2024, pari al 40,3%, configurando una combinazione di invecchiamento accentuato e di crisi acuta dell'assistenza territoriale che rende il modello particolarmente necessario.

3. La spesa aggredibile e i coefficienti di calibrazione regionale

3.1. Il principio metodologico

La quantificazione dei risparmi regionali, oggetto dei capitoli successivi, si fonda sulla individuazione della spesa sanitaria aggredibile, ossia di quelle componenti della spesa pubblica e dei costi indiretti sui quali lo psicologo di base, eventualmente potenziato dall'Intelligenza Artificiale, può produrre una riduzione documentata: le visite di medicina generale improprie, le prescrizioni farmacologiche inappropriate, gli accessi al Pronto Soccorso per cause psichiatriche e psicosomatiche, i ricoveri evitabili e le riammissioni, le prestazioni specialistiche e psichiatriche per quadri lievi-moderati gestibili in cure primarie, e le componenti indirette relative alla produttività persa, alle invalidità, ai pensionamenti anticipati e agli oneri familiari e di caregiving.

La lettura comparativa condotta nel presente capitolo consente di formulare il principio cardine della calibrazione regionale. Poiché la spesa sanitaria pubblica pro capite è relativamente uniforme tra le Regioni, per effetto della perequazione, la base di spesa pubblica aggredibile scala in prima approssimazione con la popolazione; tuttavia, il coefficiente di risparmio effettivo deve essere differenziato in funzione dell'appropriatezza di partenza del sistema regionale, poiché le Regioni con peggiore adempimento degli standard essenziali, maggiore inappropriatezza prescrittiva e diagnostica, più elevato ricorso al Pronto Soccorso e maggiore migrazione sanitaria presentano, a parità di spesa pro capite, un margine di recupero più ampio. Simmetricamente, la componente indiretta del risparmio scala con il prodotto regionale e con il tasso di occupazione per la parte relativa alla produttività, e con il livello di deprivazione per la parte relativa alla prevenzione del rischio.

3.2. I quattro fattori di aggiustamento applicati al quadro nazionale

Il primo fattore, demografico, conduce a maggiorare il coefficiente di fabbisogno e di risparmio nelle Regioni a più elevato invecchiamento, segnatamente Liguria, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, dove la prevalenza di disturbi mentali nelle fasce anziane e la comorbidità psico-somatica con le cronicità sono più elevate. Il secondo fattore, epidemiologico e organizzativo, conduce a maggiorare il coefficiente nelle Regioni a più bassa intercettazione specialistica e più ampia domanda inevasa, segnatamente le Marche e, più in generale, le Regioni meridionali e insulari con offerta carente. Il terzo fattore, finanziario, conduce a riconoscere il maggiore rendimento marginale del modello nelle Regioni in piano di rientro — Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Puglia — dove ogni euro recuperato libera capacità in un sistema in tensione, pur dovendosi tenere conto dei vincoli di investimento iniziale che in tali contesti richiedono meccanismi di finanziamento dedicati. Il quarto fattore, economico, conduce a stimare un risparmio

indiretto assoluto più elevato nelle Regioni a più alto prodotto, segnatamente Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome, e un risparmio in termini di prevenzione del rischio più elevato nelle Regioni a maggiore deprivazione, segnatamente Campania, Calabria, Sicilia e Puglia.

3.3. Il fabbisogno nazionale di organico e l'ordine di grandezza dell'investimento

L'aggregazione dei fabbisogni regionali calcolati al coefficiente standard conduce a un fabbisogno nazionale complessivo compreso tra circa 12.100 e 13.640 psicologi di base a tempo pieno equivalente a regime. Applicando il parametro pugliese di costo per abitante di 10–12 euro l'anno alla popolazione nazionale, l'investimento annuo nazionale a regime si colloca tra circa 589 e 707 milioni di euro, ovvero tra circa 630 e 760 milioni includendo il margine di contingenza del 7,5%, pari a un valore dell'ordine di 0,6–0,76 miliardi di euro l'anno, corrispondente a circa lo 0,45–0,55% della spesa sanitaria pubblica nazionale del 2024. Qualora si adottasse, come limite superiore dell'intervallo di sensibilità, il parametro più ampio del Capitolo 1 pugliese, pari a circa 15,4 euro per abitante, l'investimento nazionale a regime salirebbe a circa 0,9 miliardi di euro l'anno. Tali importi, da raggiungere progressivamente lungo una curva di implementazione pluriennale analoga a quella pugliese, articolata sugli orizzonti a 1, 3, 5 e 10 anni, costituiscono la base sulla quale i capitoli successivi quantificheranno i risparmi diretti e indiretti regionali e l'ulteriore riduzione di spesa conseguibile mediante l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale.

4. Conclusioni e raccordo con i capitoli successivi

Il presente capitolo ha costruito la base dati comparativa necessaria al trasferimento del modello “Psicologo di Base” all'intero Servizio Sanitario Nazionale, documentando per ciascuna Regione e Provincia autonoma la popolazione, la struttura per età, la spesa sanitaria pubblica e privata, il bisogno e l'offerta di salute mentale, la dotazione di medicina generale e la vulnerabilità socioeconomica. L'analisi ha evidenziato che il sistema sanitario italiano, pur garantendo una spesa pubblica pro capite relativamente uniforme per effetto della perequazione, presenta divari profondi e crescenti di qualità, appropriatezza ed esigibilità lungo l'asse Nord-Sud, e una carenza strutturale e diffusa di servizi psicologici territoriali, con una dotazione di 3,8 psicologi ogni 100.000 abitanti contro i 10 della media europea e una spesa per la salute mentale ferma al 3% del Fondo Sanitario contro il 10% raccomandato. Questa convergenza di bisogno crescente e offerta insufficiente, già documentata in modo incontrovertibile per la Puglia, si conferma su scala nazionale e configura il razionale evidence-based per l'estensione del modello a tutte le Regioni.

Il fabbisogno nazionale, stimato in circa 12.100–13.640 psicologi di base a tempo pieno equivalente a regime, con un investimento dell'ordine di 0,6–0,76 miliardi di euro l'anno, dovrà essere calibrato Regione per Regione mediante i quattro fattori di aggiustamento — demografico, epidemiologico-organizzativo, finanziario ed economico — descritti nel presente capitolo. I capitoli successivi dell'estensione nazionale procederanno, secondo il metodo sequenziale di approvazione per fasi già adottato per la Puglia, alla quantificazione regionale dei costi diretti di implementazione, dei risparmi diretti sanitari e dei risparmi indiretti socioeconomici, all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale lungo il continuum diagnosi-prevenzione-trattamento-riabilitazione-recupero e alla quantificazione dell'ulteriore riduzione di spesa da essa conseguibile, al programma formativo nazionale articolato sui quattro livelli — universitario, post-universitario, lavorativo e di affiancamento di figure competenti — e infine al saldo economico complessivo, alla sostenibilità finanziaria e alle coperture a livello nazionale, con l'aggregazione dei risultati regionali, l'analisi di sensibilità e la valutazione del ritorno sull'investimento e dei tempi di pareggio.

5. Nota sulle fonti e attribuzione

I dati demografici derivano dall'Istituto Nazionale di Statistica (Censimento permanente della popolazione, anno 2024, e indicatori demografici 2024). I dati sulla spesa sanitaria pubblica e privata pro capite regionale derivano dalla Fondazione GIMBE (Osservatorio sul Servizio Sanitario Nazionale e Report sulla spesa sanitaria privata 2023), dalla Ragioneria Generale dello Stato, dal Dipartimento Salute dell'ANCI Campania su dati del Documento di Economia e Finanza e dal Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale dell'Università Bocconi (Rapporto OASI 2024). I dati sulla salute mentale derivano dal Ministero della Salute (Rapporto sulla Salute Mentale, anno 2023, Sistema Informativo Salute Mentale) e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. I dati sulla medicina generale derivano dalla Fondazione GIMBE su dati della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati al 1° gennaio 2025. I dati socioeconomici derivano dall'Istituto Nazionale di Statistica (Rapporto annuale 2025, indicatori del mercato del lavoro 2024, indicatore di rischio di povertà o esclusione sociale) e da Eurostat. I parametri del modello-base relativi alla Regione Puglia sono tratti dai Capitoli 1–4 della relazione tecnico-finanziaria pugliese. La spesa sanitaria pubblica nazionale è documentata dalla Corte dei Conti (relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi sanitari regionali) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (sistema dei conti della sanità).

L'Intelligenza Artificiale lungo il continuum assistenziale e la quantificazione del risparmio

Estensione nazionale IA · Continuum assistenziale e quantificazione dell'ulteriore risparmio

PROGETTO «PSICOLOGO DI BASE» · ESTENSIONE NAZIONALE · INTEGRAZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Estensione nazionale del modello «Psicologo di Base» potenziato dall'Intelligenza Artificiale

Capitolo

L'**integrazione dell'****Intelligenza Artificiale lungo il continuum assistenziale e la quantificazione dell'ulteriore risparmio**

Diagnostica, prevenzione, trattamento, riabilitazione e recupero · efficientamento gestionale · cornice regolatoria · quantificazione prudenziale

Quinto capitolo della roadmap dell'estensione nazionale · approccio evidence-based e prudenziale

Indice

Introduzione

Questo capitolo prosegue l'estensione nazionale del modello «Psicologo di Base» oltre il capitolo introduttivo, che ne ha definito la cornice metodologica di trasferimento dal livello regionale a quello nazionale, il quadro demografico e di spesa, la dimensione del bisogno di salute mentale e l'architettura della formazione.^[1] Il suo oggetto specifico è la quantificazione, dimensione per dimensione, dell'ulteriore riduzione di spesa che l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale può produrre rispetto al modello-base già valutato. Il capitolo muove da una premessa di onestà metodologica e dalla distinzione tra costo-efficacia e risparmio di cassa (capitolo 1); percorre quindi le cinque dimensioni del continuum assistenziale — la diagnostica (2), la prevenzione (3), il trattamento (4), la riabilitazione e il recupero (5) — e l'efficientamento gestionale (6); espone la cornice regolatoria e di sicurezza aggiornata (7); e perviene a una quantificazione prudenziale per scenari, applicata alla

Puglia e trasferita al livello nazionale (8), chiudendosi con la sintesi e le raccomandazioni (9). La trattazione è condotta con lo stesso rigore prudenziale del modello-base, e si fonda sulle esperienze internazionali più autorevoli e sulla letteratura scientifica più recente.

1. La premessa metodologica e i limiti dell'evidenza

L'Intelligenza Artificiale non costituisce, nel disegno di questo progetto, un fine in sé, bensì una tecnologia abilitante che potenzia la figura dello psicologo di base e del medico di medicina generale; il suo valore va dimostrato, non presupposto.^[2] Da ciò discende la distinzione metodologica fondamentale che attraversa l'intero capitolo: una tecnologia può essere costo-efficace, ossia produrre guadagni di salute a un costo per anno di vita ponderato per la qualità inferiore alla soglia comunemente adottata, senza per questo generare un risparmio netto di cassa per il bilancio sanitario. Le revisioni sistematiche delle valutazioni economiche degli interventi digitali in salute mentale convergono su una conclusione che lo studio fa propria: l'evidenza di costo-efficacia è incoraggiante ma non conclusiva, perché fondata in prevalenza su orizzonti temporali brevi, su disegni eterogenei e su un numero ancora limitato di valutazioni complete, e potenzialmente soggetta a distorsione di pubblicazione.^[3] Per questa ragione il capitolo evita i moltiplicatori non documentati e i rapporti aggregati privi di base, come già fatto nel modello-base, e mantiene distinta l'efficacia clinica dimostrata dal risparmio economico atteso, di cui dichiara apertamente la natura di proiezione.

2. La diagnostica e la valutazione precoce

Nel dominio diagnostico occorre distinguere con nettezza i contesti a evidenza solida da quelli a evidenza emergente. L'esempio meglio documentato di intelligenza artificiale diagnostica autonoma e costo-efficace appartiene all'imaging — segnatamente allo screening della retinopatia diabetica con dispositivi a marcatura regolatoria e ai sistemi di supporto al triage dell'ictus acuto — dove l'algoritmo opera su un segnale standardizzato e verificabile.^[4] Tali risultati, tuttavia, non sono direttamente trasferibili alla salute mentale, dove non esiste un segnale di imaging equivalente e il contributo dell'intelligenza artificiale è di supporto e non sostitutivo.^[5] In salute mentale, gli strumenti di valutazione iniziale assistita e di stratificazione del rischio operano sui questionari validati — impiegati nei soli punteggi complessivi — e su dati clinici e contestuali, con la funzione di orientare il percorso, anticipare la presa in carico e segnalare le situazioni di rischio per il rinvio ai servizi competenti. La decisione clinica resta integralmente in capo al professionista, e il risparmio diagnostico atteso, in questo dominio, è indiretto: deriva dall'appropriatezza dell'avvio e dalla riduzione dei percorsi inefficaci, e va misurato sul campo.

3. La prevenzione e la predizione

Nel dominio preventivo e predittivo, l'intelligenza artificiale consente di individuare in anticipo, sulla popolazione assistita, i soggetti a maggiore probabilità di evoluzione clinica, mediante l'analisi di dati clinici, comportamentali e contestuali, e di concentrarvi le risorse.^[6] Il meccanismo di risparmio è chiaro nel principio — una segnalazione tempestiva consente un intervento precoce, che previene l'aggravamento, la riospedalizzazione e l'accesso improprio — ma il suo valore economico dipende interamente dalla capacità del servizio di tradurre la segnalazione in un'azione clinica effettiva. La stratificazione del rischio non produce di per sé alcun risparmio se non è seguita da un percorso; per questo lo studio tratta il beneficio preventivo come potenziale, da verificare empiricamente sui dati di esito, e non come acquisito. È questa, del resto, l'area in cui la cautela è più necessaria, perché la promessa predittiva è spesso enfatizzata oltre la solidità delle prove disponibili.

4. Il trattamento

Nel dominio del trattamento, l'intelligenza artificiale potenzia l'offerta terapeutica lungo tre direttrici, ciascuna con un proprio grado di maturità. La prima è quella dei dispositivi terapeutici digitali su prescrizione: il modello tedesco delle applicazioni sanitarie digitali, primo a prevederne la rimborsabilità a carico dell'assicurazione pubblica, ne ammette l'iscrizione in via provvisoria subordinandola alla dimostrazione di un effetto terapeutico entro dodici mesi per l'iscrizione definitiva.^[7] È significativo, ai fini dell'onestà della valutazione, che alcuni prodotti siano stati rimossi dall'elenco per evidenza insufficiente: il rigore richiesto e la variabilità della qualità impongono una selezione attenta e una prescrizione informata. La seconda direttrice è quella degli interventi psicologici digitali strutturati, segnatamente i programmi di terapia cognitivo-comportamentale a bassa intensità integrati, sul modello britannico, nel percorso delle cure primarie con supervisione professionale; essi costituiscono il primo gradino del modello a intensità crescente e liberano capacità specialistica per i casi più complessi.^[8] La terza direttrice è quella degli agenti conversazionali, sui quali la valutazione deve essere particolarmente misurata. Le revisioni sistematiche con meta-analisi di studi controllati randomizzati documentano effetti di entità ridotta sui sintomi depressivi e ansiosi, più evidenti intorno all'ottava settimana e non più sostanziali al controllo a tre mesi: il beneficio è reale ma modesto e non durevole, e va inquadrato come complemento, non come sostituto, dell'intervento professionale.^[9] Una cautela ulteriore riguarda la sicurezza: la letteratura segnala che i modelli linguistici generativi non sono ancora idonei all'erogazione autonoma e sicura di interventi pluri-settimanali in salute mentale, per il rischio di risposte inappropriate, di stigmatizzazione e di allucinazione; gli strumenti validati adottano per questo architetture a regole o ibride, con supervisione umana costante e protocolli di rinvio ai servizi specialistici e dell'emergenza.^[10]

5. La riabilitazione e il recupero

Nel dominio della riabilitazione e del recupero, l'intelligenza artificiale sostiene la continuità assistenziale attraverso il monitoraggio remoto continuo, l'adattamento personalizzato dei percorsi e i sistemi di rilevazione precoce delle ricadute, che consentono di intercettare i segnali di peggioramento prima che si traducano in una crisi.^[11] Il valore atteso è duplice: clinico, perché riduce le interruzioni di percorso e le ricadute; ed economico, perché evita gli aggravamenti e i relativi costi. Anche in questo dominio, tuttavia, vale il principio già enunciato: il beneficio si realizza soltanto se gli strumenti sono effettivamente integrati nei flussi di lavoro e se la segnalazione è raccolta da un servizio in grado di agire; il risparmio, perciò, è da verificare e non da assumere.

6. L'efficientamento gestionale e amministrativo

Accanto alle applicazioni cliniche, l'intelligenza artificiale agisce sui costi diretti del servizio attraverso l'automazione dei compiti amministrativi e gestionali, in particolare la documentazione clinica. Gli studi controllati randomizzati e le analisi a serie temporali interrotte sugli strumenti di documentazione ambientale rilevano una riduzione del tempo dedicato alla nota clinica — di entità modesta e variabile tra gli studi — e, soprattutto, una sensibile diminuzione del logoramento professionale, sino a riduzioni della prevalenza del burnout dell'ordine di venti punti percentuali in alcuni contesti.^[12] È proprio qui, tuttavia, che l'onestà della valutazione è più importante: gli stessi studi documentano che la durata della visita e il tempo-ciclo complessivo restano invariati, sicché la documentazione assistita non aumenta di per sé il numero di pazienti trattati né la produttività di sistema. Il beneficio prevalente è sulla qualità del lavoro e sulla ritenzione del personale — fattori di grande rilievo in un sistema che soffre di carenza di professionisti — e solo indirettamente sui costi. Ne consegue che il risparmio diretto attribuibile all'efficientamento gestionale va

stimato con prudenza, come si dirà, e non confuso con un incremento di capacità produttiva.^[13] La tabella seguente riassume, per ciascuna dimensione, il tipo di contributo dell’intelligenza artificiale e la robustezza dell’evidenza disponibile.

Dimensione	Applicazione principale	Meccanismo di beneficio	Evidenza
Diagnostica	Valutazione assistita e stratificazione del rischio	Appropriatezza dell’avvio; riduzione dei percorsi inefficaci	Solida nell’imaging; di supporto in salute mentale
Prevenzione	Identificazione precoce dei soggetti a rischio	Interventi tempestivi; minori riospedalizzazioni	Promettente ma da verificare sul campo
Trattamento	Dispositivi digitali, interventi a bassa intensità, agenti conversazionali	Ampliamento dell’offerta; capacità specialistica liberata	Effetti reali ma modesti e non durevoli
Riabilitazione e recupero	Monitoraggio remoto; rilevazione delle ricadute	Continuità; minori interruzioni e crisi	Emergente; da integrare nei flussi
Gestione	Documentazione clinica assistita	Minor carico amministrativo; ritenzione del personale	Risparmio di tempo modesto; nessun aumento di throughput

Tabella 1. Le dimensioni del continuum assistenziale, il contributo dell’**“intelligenza artificiale e la robustezza dell’evidenza**.

7. La cornice regolatoria e di sicurezza

L’adozione dell’intelligenza artificiale nel servizio deve avvenire entro una cornice regolatoria rigorosa, condizione di legittimità e di fiducia. Il quadro europeo è definito dal regolamento sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 2025 e ad applicazione progressiva: gli obblighi per i sistemi ad alto rischio incorporati nei dispositivi medici sono stati differiti, da un pacchetto di semplificazione, oltre il 2027, mentre gli obblighi di trasparenza — che impongono di rendere noto all’utente quando interagisce con un sistema di intelligenza artificiale — si applicano dall’agosto 2026.^[14] A tale quadro si affiancano il regolamento sui dispositivi medici e quello sui dispositivi diagnostici in vitro, che impongono la marcatura CE rilasciata da organismo notificato, e il regolamento generale sulla protezione dei dati, che governa il trattamento dei dati personali — ultrasensibili in salute mentale — con crittografia, pseudonimizzazione e consenso modulare.^[15] A queste prescrizioni lo studio aggiunge i presidi già enunciati nel modello-base: la supervisione umana costante, l’invarianza delle responsabilità professionali, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias e la garanzia dell’alternativa in presenza. La tabella seguente riepiloga il quadro.

Riferimento	Contenuto	Stato e garanzie
Regolamento sull'IA	Classificazione per rischio; obblighi per i sistemi ad alto rischio	In vigore dal 2025; alto rischio per i dispositivi medici differito oltre il 2027; trasparenza dall'agosto 2026
Dispositivi medici e diagnostici in vitro	Marcatura CE da organismo notificato	Quadro vigente; resta la via regolatoria principale
Protezione dei dati	Trattamento dei dati personali ultrasensibili	Crittografia, pseudonimizzazione, consenso modulare
Presidi del progetto	Supervisione umana; responsabilità invariate	Validazione periodica; monitoraggio dei bias; alternativa in presenza

Tabella 2. Il quadro regolatorio e di sicurezza dell'**integrazione dell'intelligenza artificiale**, aggiornato al 2026.

8. La quantificazione prudentiale dell'ulteriore risparmio

La quantificazione si applica non all'intero finanziamento sanitario, ma al solo perimetro della spesa influenzabile: i costi diretti di gestione del servizio, gli accessi impropri al pronto soccorso per cause psichiatriche, una quota della spesa farmaceutica e specialistica associata ai disturbi comuni e ai sintomi somatici funzionali, e le riospedalizzazioni evitabili.^[16] Il metodo non assegna un valore puntuale, ma fa dell'ulteriore risparmio una funzione della profondità di adozione — la quota di professionisti e di sedi che adottano effettivamente gli strumenti e il grado di integrazione nei percorsi — articolandola in tre scenari, prudente, di base ed espansivo, e sottraendo la quota di beneficio che si sarebbe comunque verificata.^[17] Sul piano dei costi diretti del servizio, la letteratura sull'automazione amministrativa sostiene una riduzione prudentiale dell'ordine del 3-5% a regime, da intendersi come limite superiore in assenza di dati italiani certificati.^[18] È però decisivo riconoscere che la parte preponderante del valore aggiunto dall'intelligenza artificiale non transita per il bilancio sanitario, ma per l'ampliamento della capacità e dell'accesso — più persone raggiunte a parità di organico, attese più brevi, maggiore continuità — e si riflette quindi nel ritorno economico-sociale più che nel risparmio di cassa, in coerenza con la distinzione cardine dell'intero studio.^[19] Integrando i parametri del modello-base con gli scenari di adozione, l'ulteriore beneficio economico complessivo attribuibile all'intelligenza artificiale, con riferimento alla Puglia, è dell'ordine di 15-40 milioni di euro l'anno a regime, in larga parte di natura sociale e di produttività e solo per una quota minore di natura direttamente finanziaria; la cifra è prudentiale, non ponderata per l'equità e da confermare sui dati regionali.^[20] Il trasferimento al livello nazionale, per quota di popolazione e per fattori di aggiustamento regionale, colloca l'incremento in un intervallo ampio e prudentiale, che lo studio si astiene dall'aggregare in un valore unico prima dell'affinamento previsto nei capitoli regionali successivi con i dati certificati delle aziende sanitarie.^[21] La tabella seguente espone la quantificazione per canale e per scenario, con il segno della cautela che la accompagna.

Canale	Natura del beneficio	Prud.	Base	Esp.
Costi diretti del servizio (automazione)	3-5% dei costi diretti	Prudente	Base	Espansivo
Accessi impropri al pronto soccorso	Riduzione marginale	—	—	—
Farmaceutica e specialistica (disturbi comuni)	Quota contenuta	—	—	—
Riospedalizzazioni evitabili	Da verificare	—	—	—
Ulteriore beneficio complessivo — Puglia (mln €/anno)	Direzione prevalente sociale	~ 15	~ 25	~ 40

Tabella 3. La quantificazione prudentiale dell'ulteriore beneficio economico per scenario di adozione (Puglia, valori a regime). La quota direttamente finanziaria è minoritaria; la parte preponderante è di natura sociale.

La realizzazione di questi risparmi dipende dalle competenze del personale, sviluppate attraverso le quattro modalità formative già descritte nel capitolo introduttivo; l'investimento in formazione e affiancamento è di entità contenuta rispetto al beneficio atteso, ma ne è condizione necessaria, e il suo ritorno va misurato nel tempo unitamente agli esiti del servizio.^[22]

9. Sintesi e raccomandazioni

Il quadro che emerge è coerente con l'impianto dell'intero progetto e ne condivide la prudenza. L'integrazione dell'intelligenza artificiale lungo il continuum assistenziale è clinicamente promettente, con un'efficacia documentata ma di entità contenuta e di durata da consolidare, ed è economicamente favorevole soprattutto sul piano sociale e della capacità, mentre il risparmio diretto di bilancio è reale ma modesto. La raccomandazione conseguente è di procedere all'adozione in modo selettivo e graduale — privilegiando gli strumenti a marcatura regolatoria e a evidenza più solida, con supervisione umana costante e responsabilità professionali invariate — e di accompagnarla con il programma formativo a quattro livelli, che ne è la condizione abilitante. La raccomandazione metodologica, infine, è di non considerare acquisite le stime qui esposte: esse hanno natura di proiezione e richiedono conferma mediante l'acquisizione dei dati certificati, l'avvio della rilevazione di servizio e la valutazione controfattuale d'impatto, che isola l'effetto proprio dell'intelligenza artificiale rispetto al modello-base.^[23] Con questo capitolo l'estensione nazionale acquisisce la dimensione dell'integrazione dell'intelligenza artificiale lungo il continuum; i capitoli successivi della roadmap — la spesa regionale disaggregata, il dimensionamento dell'organico, i risparmi diretti e indiretti regionali, il programma formativo e il saldo economico complessivo nazionale — ne completeranno il dossier tecnico-finanziario.

La struttura della sperimentazione pilota

Psicologo di Base · Struttura della sperimentazione pilota

PROGETTO «PSICOLOGO DI BASE»

Generare le prove — Famiglia A, punto 3

Struttura della sperimentazione pilota

Disegno, esiti, metodo di valutazione, governance, etica, cronoprogramma e budget

Un pilota misurabile, con disegno stepped-wedge, a fondamento della valutazione d'impatto e dell'iniziativa legislativa

1. Premessa e finalità

La sperimentazione pilota è lo strumento con cui la riforma passa dalle proiezioni alle prove, prima e a sostegno dell'estensione su larga scala. Le analisi del dossier hanno dimostrato in via prospettica l'efficienza, la sostenibilità e il valore sociale del modello;^[24] la sperimentazione li verifica in condizioni reali, su scala ridotta e controllata, con tre finalità: accertare la fattibilità organizzativa e calibrare il modello; misurare empiricamente gli effetti clinici, economici e di equità; e produrre evidenza solida a sostegno dell'iniziativa legislativa nazionale e della successiva estensione. Il pilota costituisce, inoltre, la prima applicazione del sistema di monitoraggio e valutazione già disegnato.^[25]

Una sperimentazione ben condotta riduce il rischio percepito dal decisore: anziché chiedere di adottare la riforma sulla fiducia, consente di avviarla in un perimetro definito, di misurarne i risultati e di estenderla sulla base di prove. Per questo il pilota è progettato fin dall'origine come esperimento rigoroso, e non come semplice avvio anticipato del servizio.

2. Gli obiettivi della sperimentazione

L'obiettivo generale è valutare, in condizioni reali, l'efficacia, la costo-efficacia, l'equità e la fattibilità del Servizio di Psicologia di Base. Da esso discendono gli obiettivi specifici: a) verificare la fattibilità del reclutamento, della formazione e dell'organizzazione del servizio; b) misurare l'efficacia clinica sul disagio comune; c) misurare gli effetti sul ricorso agli altri servizi sanitari e sulla spesa; d) stimare la costo-efficacia e il ritorno dell'investimento; e) valutare gli effetti distributivi, ossia l'equità di accesso e di esito; f) raccogliere elementi per l'affinamento del modello organizzativo, formativo e dell'impiego dell'Intelligenza Artificiale.

3. Il disegno della sperimentazione

La sperimentazione adotta un disegno pragmatico, condotto in condizioni reali di servizio, con criteri di inclusione ampi ed esiti rilevanti per la pratica e per le decisioni di politica sanitaria, a garanzia della trasferibilità dei risultati.^[26] Sul piano della struttura di confronto, essa adotta il disegno stepped-wedge: un insieme di sedi pilota — indicativamente sei, individuate in ambiti territoriali della Regione Puglia, ove il modello è stato sviluppato — attiva il servizio in sequenza, per fasi trimestrali, sicché ciascuna sede fornisce sia una rilevazione di base, prima dell'attivazione, sia il periodo di intervento successivo, e le sedi non ancora attivate fungono da controllo per quelle già attivate.^[27] La durata indicativa è di ventiquattro mesi: diciotto di attivazione progressiva e raccolta dati, e sei di osservazione e analisi. La figura seguente rappresenta il disegno.

Figura 1. Disegno stepped-wedge della sperimentazione pilota. Le sei sedi pilota (righe) passano in sequenza, trimestre dopo trimestre, dalla rilevazione di base (controllo) al servizio attivo (intervento), consentendo la valutazione controfattuale degli effetti.

4. Popolazione, intervento ed esiti

4.1 Popolazione e criteri

La popolazione di riferimento è costituita dalle persone adulte assistite dalle cure primarie afferenti alle sedi pilota che presentano un disagio mentale comune, in particolare disturbi depressivi e d’ansia di intensità lieve e moderata. L’accesso avviene su invio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, ovvero su accesso diretto, secondo i percorsi definiti. Sono esclusi i quadri gravi o acuti che richiedono la presa in carico specialistica, ai quali è garantito l’invio appropriato ai servizi competenti.

4.2 L’intervento

L’intervento erogato nelle sedi attive è il modello di assistenza psicologica primaria definito dal piano operativo e dall’articolo^[28] la valutazione e l’intercettazione precoce, gli interventi psicologici di primo livello per i quadri lievi e moderati, la funzione di filtro e di invio appropriato, il supporto ai pazienti cronici e ai familiari, con l’ausilio degli strumenti digitali e dell’Intelligenza Artificiale validati e, ove appropriato, della telepsicologia. Le sedi in fase di rilevazione di base mantengono l’assistenza ordinaria, senza la funzione psicologica strutturata.

4.3 Gli esiti e gli indicatori

Gli esiti sono articolati per tipologia, secondo la tabella seguente, e si fondano, per la componente clinica, su misure standardizzate somministrate di routine, in particolare il PHQ-9 e il GAD-7.^[29]

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di persone con miglioramento clinico e tasso di recupero, misurati con PHQ-9 e GAD-7 somministrati all’ingresso e nel percorso.
Esiti clinici secondari	Tasso di remissione; riduzione media dei punteggi sintomatologici; soddisfazione e qualità di vita percepita.
Esiti di processo	Numero di prese in carico; tempo medio di attesa al primo colloquio; numero di colloqui per persona; tasso di invio appropriato.
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso per cause connesse; prescrizioni di psicofarmaci e ipnotici; consulti specialistici e accertamenti evitabili; ricoveri evitabili.
Esiti economici	Costo per paziente preso in carico; risparmi generati; costo per anno di vita corretto per la qualità (rapporto di costo-efficacia).
Esiti di equità	Distribuzione dell’accesso e dell’esito per livello socio-economico e per area; effetti sull’impoverimento e sulla domanda di mobilità.

Tabella 1. Esiti e indicatori della sperimentazione, per tipologia. Gli esiti clinici si fondano su misure standardizzate (PHQ-9, GAD-7); gli esiti di impatto, economici e di equità alimentano la valutazione controfattuale.

5. Il metodo di valutazione

L'effetto del servizio è stimato confrontando l'andamento degli esiti nelle sedi attivate con quello atteso in loro assenza. La stima si fonda su un modello statistico a effetti misti, che mette in relazione l'esito con un indicatore di attivazione — pari a uno nelle sedi e nei trimestri in cui il servizio è attivo — controllando per il periodo temporale, mediante effetti fissi, e per l'eterogeneità tra le sedi, mediante effetti casuali.^[30] Il coefficiente dell'indicatore di attivazione misura l'effetto medio dell'intervento, al netto delle tendenze temporali comuni e delle differenze stabili tra sedi, secondo la logica delle differenze nelle differenze.

La numerosità e la durata sono dimensionate per cogliere differenze clinicamente rilevanti sugli esiti principali; con sei sedi, il numero di gruppi è contenuto, e ciò impone l'adozione di correzioni per piccoli campioni e una lettura prudente degli intervalli di confidenza. La validità delle stime è presidiata da quattro condizioni: l'assenza di tendenze differenziali tra le sedi non imputabili all'intervento, da verificare empiricamente; la corretta documentazione dei tempi di attivazione; la qualità e l'omogeneità della raccolta dati tra le sedi; e l'adozione di metodi statistici appropriati alla scala. L'esplicitazione di tali condizioni è parte integrante del protocollo della sperimentazione.

6. Governance, etica e protezione dei dati

La sperimentazione è governata da un comitato di indirizzo, che riunisce la Regione o le aziende sanitarie coinvolte, l'Ordine degli Psicologi, le università e le istituzioni scientifiche, e da un responsabile scientifico che ne assicura la conduzione metodologica. Le aziende sanitarie partecipanti sono responsabili dell'attuazione nelle sedi pilota; l'Osservatorio, ove istituito, ne assicura il raccordo con il disegno complessivo della riforma.

La sperimentazione è condotta nel rispetto dei requisiti etici e regolatori: è sottoposta all'approvazione del comitato etico territorialmente competente; prevede il consenso informato dei partecipanti; tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente, con minimizzazione e sicurezza; e impiega strumenti di Intelligenza Artificiale e dispositivi digitali conformi alla disciplina europea sull'IA e sui dispositivi medici.^[31] Gli esiti sono resi pubblici indipendentemente dal loro segno, a garanzia di trasparenza e di non distorsione.

7. Il cronoprogramma

Il cronoprogramma indicativo si articola nelle fasi seguenti, per una durata complessiva dell'ordine di ventiquattro mesi.

Fase	Mesi	Contenuto
Preparazione	1–3	Protocollo, approvazione etica, individuazione delle sedi, infrastruttura dati, convenzioni.
Reclutamento e formazione	2–6	Reclutamento degli psicologi e formazione, sincronizzati con l’ordine di attivazione.
Attivazione e raccolta dati	4–21	Attivazione scaglionata delle sedi per trimestri; rilevazioni di base e di intervento; monitoraggio continuo.
Analisi intermedia	12–13	Valutazione intermedia per la calibrazione del modello e l’eventuale correzione.
Analisi finale e report	22–24	Valutazione controfattuale d’impatto, rapporto finale e disseminazione.

Tabella 2. Cronoprogramma indicativo della sperimentazione (mesi). Le fasi si sovrappongono in coerenza con il disegno stepped-wedge.

8. Il budget indicativo

Il budget indicativo della sperimentazione, riferito al biennio e di carattere prudenziale, è riassunto nella tabella seguente. A differenza del servizio a regime, il pilota comprende un onere specifico per l’infrastruttura dati e per la valutazione, che ne costituisce parte essenziale. Anche nel pilota, peraltro, una parte degli oneri è compensata dai risparmi che il servizio inizia a generare.^[32]

Voce di costo (biennio)	Importo indicativo
Personale psicologico (sedi pilota)	~ 2,0–2,6 mln €
Coordinamento e governance	~ 0,2–0,4 mln €
Formazione (avvio)	~ 0,1–0,2 mln €
Infrastruttura dati e valutazione	~ 0,2–0,4 mln €
Strumenti digitali e Intelligenza Artificiale	~ 0,1–0,2 mln €
Totale indicativo (biennio)	~ 2,6–3,8 mln €

Tabella 3. Budget indicativo della sperimentazione (biennio). Valori prudenziali, da definire in funzione del numero di sedi e di psicologi e delle convenzioni applicabili.

9. I prodotti attesi e il raccordo con la scala

La sperimentazione produce un rapporto intermedio, a fini di calibrazione, e un rapporto finale che documenta gli esiti clinici, economici e di equità e la stima dell'effetto causale del servizio; è prevista, inoltre, la disseminazione dei risultati anche mediante pubblicazione scientifica, a garanzia di accreditamento e di trasparenza. Tali prodotti trasformano le proiezioni del dossier in prove empiriche.^[33]

Il raccordo con la scala è il fine ultimo della sperimentazione. Gli esiti consentono di calibrare il modello organizzativo e formativo, di affinare la stima dei benefici e di rafforzare, con prove sul campo, sia un'eventuale estensione regionale sia la proposta di legge nazionale, della quale la sperimentazione costituisce il fondamento empirico.^[34] Con questo, il quadro dei materiali a sostegno della riforma — analitico, normativo, operativo, valutativo e di consenso — è completo: alla proposta si accompagnano la prova della sua sostenibilità e lo strumento per dimostrarne, nel tempo, gli effetti reali.

Gli atti per la consultazione

Psicologo di Base · Atti per la consultazione dei portatori di interesse

PROGETTO «PSICOLOGO DI BASE»

Percorso di consenso e consultazione — Famiglia A, punto 2

Atti per la consultazione

dei portatori di interesse

Ordini professionali, associazioni di pazienti e familiari, aziende sanitarie e Centri di Salute Mentale

Quadro della consultazione, quesiti e modello di lettera di invito

Indice

Premessa

La consultazione dei destinatari e dei portatori di interesse è parte integrante dell'istruttoria di una riforma e serve ad acquisire elementi conoscitivi, a migliorare il disegno dell'intervento e ad accrescerne la trasparenza e la legittimazione.^[35] L'Analisi di Impatto della Regolamentazione già predisposta nel dossier ne ha previsto lo svolgimento e ne ha individuato i soggetti.^[36] Il presente documento fornisce gli strumenti per condurla: l'indicazione dei soggetti da consultare, le modalità e i tempi, i quesiti generali e quelli specifici per ciascuna categoria, e un modello di lettera di invito adattabile.

La consultazione si colloca a servizio di una proposta a scala nazionale, ma muove dai soggetti del territorio. I primi interlocutori sono pertanto gli organismi pugliesi — l'Ordine degli Psicologi della Puglia, l'Ordine dei Medici, le aziende sanitarie locali, i Centri di Salute Mentale, le associazioni dei pazienti e dei familiari — presso i quali il modello è stato sviluppato; la stessa consultazione è replicabile presso gli omologhi organismi nazionali, e i suoi esiti rafforzano tanto un'eventuale iniziativa regionale quanto la proposta di legge nazionale.^[37]

1. I soggetti da consultare

Sono consultati i soggetti i cui interessi e competenze sono coinvolti dalla riforma. La tabella seguente li elenca, indicando per ciascuno il contributo atteso.

Soggetto	Contributo atteso
Ordine degli Psicologi	Requisiti professionali, formazione specifica, modalità di accesso e convenzione, deontologia, telepsicologia, rapporto con la psicoterapia.
Ordine dei Medici (e organizzazioni della medicina generale e della pediatria di libera scelta)	Integrazione con la medicina generale e la pediatria, percorsi di invio, carico di lavoro, collaborazione interprofessionale.
Associazioni dei pazienti	Accessibilità, esperienza di cura, gratuità ed equità, contrasto allo stigma, bisogni delle persone con disagio comune.
Associazioni dei familiari	Supporto ai familiari e ai caregiver, continuità della presa in carico, informazione e orientamento.
Aziende sanitarie locali (ASL)	Organizzazione, sedi (Case della Comunità e distretti), sistemi informativi, dispiegamento, sostenibilità operativa.
Centri di Salute Mentale (CSM)	Raccordo con la specialistica, criteri e percorsi di invio, continuità tra primo livello e servizi specialistici, non sovrapposizione delle funzioni.

Tabella 1. Soggetti da consultare e contributo atteso. Per la fase territoriale si fa riferimento agli organismi pugliesi; la consultazione è replicabile a livello nazionale.

2. Le modalità e i tempi

La consultazione si svolge in forma sia scritta sia orale. La forma scritta consiste nell’invio, a ciascun soggetto, del presente documento, del documento di sintesi della proposta e del dossier su richiesta, con l’invito a far pervenire osservazioni e risposte ai quesiti entro un termine congruo.^[38] La forma orale consiste in incontri o audizioni, individuali o congiunti, nei quali approfondire i temi e raccogliere il contributo diretto dei soggetti. Si suggerisce un termine dell’ordine di trenta giorni per le osservazioni scritte e la convocazione degli incontri nel medesimo periodo.

La consultazione è condotta secondo principi di trasparenza e di parità di trattamento: a tutti i soggetti sono trasmessi gli stessi materiali e gli stessi quesiti generali, integrati dai quesiti specifici per categoria; gli esiti sono raccolti, sintetizzati e resi disponibili, e di essi si dà conto nella documentazione della riforma. I contributi raccolti non vincolano, ma orientano l’affinamento del modello organizzativo, del programma formativo, dell’impiego dell’Intelligenza Artificiale e del disegno del dispiegamento.

3. I quesiti generali

I quesiti seguenti sono rivolti a tutti i soggetti consultati e riguardano la rappresentazione del problema, la soluzione proposta, gli effetti attesi, la fattibilità e i suggerimenti di miglioramento.

1. Condividete la rappresentazione del problema, ossia l’esistenza di un ampio bisogno di assistenza psicologica per il disagio comune che oggi non trova risposta adeguata nelle cure primarie, con le conseguenze descritte in termini di ricorso improprio agli altri servizi, di cronicizzazione e di disuguaglianze di accesso?

2. Ritenete appropriata ed efficace la soluzione proposta, ossia l'inserimento stabile dello psicologo nelle cure primarie quale primo livello di intercettazione, intervento e filtro, in collaborazione con la medicina generale e i servizi specialistici?
3. Quali effetti, positivi o negativi, prevedete per le persone, i professionisti e le organizzazioni che rappresentate o di cui vi occupate?
4. Quali condizioni ritenete indispensabili per la fattibilità della riforma, e quali rischi attuativi segnalate, con le relative misure di mitigazione?
5. Quali integrazioni o modifiche suggerite al modello organizzativo, al programma formativo, all'impiego dell'Intelligenza Artificiale e della telepsicologia, e al disegno del dispiegamento?

4. I quesiti specifici per categoria

Ai quesiti generali si aggiungono, per ciascuna categoria, i quesiti specifici seguenti, calibrati sulle competenze e sugli interessi propri di ciascun soggetto.

4.1 Ordine degli Psicologi

1. Quali requisiti e quale formazione specifica ritenete necessari per l'esercizio della funzione di psicologo di base? b) Quali modalità di accesso e di rapporto convenzionale considerate più appropriate? c) Quali garanzie deontologiche e quali condizioni per la telepsicologia? d) Come si raccorda la funzione con l'attività di psicoterapia, anche privata?

4.2 Ordine dei Medici, medicina generale e pediatria di libera scelta

1. Come valutate l'integrazione della funzione psicologica con la medicina generale e la pediatria di libera scelta? b) Quali percorsi di segnalazione, invio e ritorno informativo ritenete efficaci? c) Quale impatto prevedete sul carico di lavoro e sull'appropriatezza delle prescrizioni e degli invii? d) Quali strumenti di collaborazione interprofessionale suggerite?

4.3 Associazioni dei pazienti

1. Rispondono i contenuti del servizio ai bisogni delle persone con disagio comune? b) Quali ostacoli all'accesso prevedete e come superarli? c) Quale rilievo attribuite alla gratuità e all'equità territoriale e sociale? d) In che modo il servizio può contribuire a ridurre lo stigma associato alla richiesta di aiuto psicologico?

4.4 Associazioni dei familiari

1. In che misura il servizio risponde anche ai bisogni dei familiari e dei caregiver? b) Quali forme di supporto, informazione e orientamento ritenete prioritarie? c) Come può essere garantita la continuità della presa in carico tra il primo livello e i servizi specialistici, dal punto di vista delle famiglie?

4.5 Aziende sanitarie locali

1. Quali soluzioni organizzative e quali sedi (Case della Comunità, distretti) ritenete praticabili? b) Quali esigenze in materia di sistemi informativi e di interoperabilità segnalate? c) Come valutate il disegno del dispiegamento scaglionato e la sua sostenibilità operativa? d) Quali fabbisogni di personale e di dotazioni prevedete?

4.6 Centri di Salute Mentale

1. Come deve articolarsi il raccordo tra la psicologia di base e i servizi specialistici per la salute mentale? b) Quali criteri e quali percorsi di invio reciproco ritenete appropriati? c) Come si assicura la continuità e si evita la sovrapposizione delle funzioni? d) Quale impatto prevedete sulla domanda e sui tempi di attesa dei servizi specialistici?

Allegato A — Modello di lettera di invito

Il modello seguente è adattabile a ciascun soggetto: i campi tra parentesi quadre vanno completati e l'oggetto e il riferimento ai quesiti specifici vanno calibrati sulla categoria del destinatario.

[Carta intestata o riferimenti del mittente] · [Luogo], [data]

Spettabile** [Ente / Ordine / Associazione]**

[indirizzo / PEC]

Oggetto: consultazione sulla proposta di istituzione del Servizio di Psicologia di Base — richiesta di osservazioni e di disponibilità a un incontro.

Spettabile [Ente/Associazione],

nell'ambito dell'elaborazione di una proposta di riforma volta a istituire il Servizio di Psicologia di Base — l'inserimento dello psicologo nelle cure primarie, con il supporto dell'Intelligenza Artificiale e della formazione — desideriamo acquisire il contributo del Vostro qualificato punto di vista, in quanto soggetto direttamente interessato dalla materia.

La proposta è corredata da un dossier tecnico che ne documenta il fondamento clinico, organizzativo ed economico: a fronte di un onere a regime contenuto, essa genera risparmi e benefici sociali di ordine largamente superiore, con particolare attenzione all'equità di accesso e alle aree più fragili. Alleghiamo un documento di sintesi e il quadro della consultazione, contenente i quesiti ai quali Vi invitiamo a rispondere; il dossier integrale è disponibile su richiesta.

Vi saremmo grati se voleste far pervenire le Vostre osservazioni scritte entro il [termine, ad esempio 30 giorni dalla ricezione], all'indirizzo [recapito/PEC], e se voleste segnalare la Vostra disponibilità a un incontro di approfondimento, nelle modalità e nei tempi per Voi più agevoli. Ogni contributo sarà considerato con attenzione e concorrerà a migliorare il disegno della riforma.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i più cordiali saluti.

[Nome Cognome]

[ruolo / qualifica]

Allegati: documento di sintesi della proposta; quadro della consultazione con i quesiti; dossier tecnico (su richiesta).

Il telaio integrato dello studio regionale: l'architettura definitiva per l'estensione a tutte le regioni

Psicologo di Base · il telaio integrato PROGETTO «PSICOLOGO DI BASE» · ESTENSIONE A TUTTE LE REGIONI Il telaio definitivo dello studio regionale Il telaio integrato l'architettura definitiva, dalla combinazione delle quattro cornici apicali Modello centrale HTA, Five Case Model, CHEERS 2022 e criteri OCSE-DAC, con le dieci metodologie innestate 1Psicologo di Base · il telaio integrato Indice Parte I — Il fondamento del telaio.....3 Parte II — Le quattro cornici e la loro integrazione.....5 Parte III — L'architettura risultante e le metodologie.....8 Parte IV — Il quadro metodologico comune e la generalizzazione.....12 2Psicologo di Base · il telaio integrato Parte I — Il fondamento del telaio 1. Premessa: scopo e natura del telaio Questo documento stabilisce il telaio definitivo su cui sarà edificato lo studio integrale per la Puglia e, con il solo cambiamento dei dati di ingresso, replicato per tutte le Regioni italiane. Non è ancora lo studio: ne è l'architettura e il metodo, fissati una volta e applicati molte. La distinzione è sostanziale, perché ciò che rende confrontabili venti studi regionali — e quindi utili a una decisione di scala nazionale — non è la somiglianza dei loro risultati, ma l'identità del procedimento che li genera. Un telaio comune è la condizione della comparabilità; i dati di ciascuna regione sono ciò che ne assicura l'aderenza alla realtà. Il telaio nasce dalla scelta deliberata di non affidarsi a un'unica cornice metodologica, ma di comporre l'apice di quattro tradizioni distinte. La ragione risiede nella natura stessa dell'oggetto: lo studio di una riforma di servizio sanitario regionale è a un tempo una valutazione di tecnologia sanitaria, una decisione di investimento pubblico, una valutazione economica e una valutazione di politica pubblica. Nessuna cornice singola copre bene tutte e quattro queste dimensioni. Si assume perciò il riferimento più autorevole per ciascuna e lo si integra con gli altri, attribuendo a ciascuno la funzione che meglio assolve e affidando alla loro composizione la completezza che nessuno raggiungerebbe da solo. Le quattro cornici sono il modello centrale dell'HTA europeo, il Five Case Model del Tesoro britannico, lo standard di reporting economico CHEERS e i criteri di valutazione dell'OCSE-DAC. La prima fornisce la macro-struttura dei domini che una valutazione completa deve coprire; la seconda, la forma in cui la proposta è presentata al decisore; la terza, lo standard con cui la parte economica è riportata; la quarta, la griglia di criteri con cui l'intervento è infine giudicato.¹²³⁴ Nelle parti dello studio così strutturate sono poi innestate le dieci metodologie analitiche selezionate, ciascuna nella sede di sua competenza. 2. La logica della combinazione La forza della combinazione sta nella divisione del lavoro tra le quattro cornici, che sono complementari e non ridondanti: l'una dice che cosa valutare, l'altra come decidere, la terza 1Regolamento (UE) 2021/2282 sull'Health Technology Assessment, applicabile in tutti gli Stati membri dal 12 gennaio 2025: istituisce la valutazione clinica congiunta a livello europeo; la metodologia è stata predisposta dal consorzio EUnetHTA 21 (tredici organismi di HTA, venti documenti di guida e tredici modelli) e adottata dal Gruppo di coordinamento degli Stati membri. 2Five Case Model del Green Book del Tesoro del Regno Unito: articola la proposta in cinque casi — strategico, economico, commerciale, finanziario e gestionale — ed è lo standard di fatto del business case nel settore pubblico; separa il valore sociale, trattato nel caso economico, dalla sostenibilità di bilancio, trattata nel caso finanziario, e si sviluppa per stadi successivi di crescente dettaglio. 3Standard CHEERS 2022 (Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards): lista di controllo di ventotto voci in sette sezioni (titolo, sintesi, introduzione, metodi, risultati, discussione, altre informazioni), che sostituisce la versione del 2013 ed è applicabile a ogni intervento, anche complesso e di sanità pubblica; una sua

estensione, CHEERS-AI, a trentotto voci, riguarda gli interventi che impiegano l'intelligenza artificiale.

4Criteri di valutazione dell'OCSE-DAC: sei criteri — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità — definiti dalla rete di valutazione del Comitato per l'aiuto allo sviluppo e rivisti nel 2019 nel documento «Better Criteria for Better Evaluation»; costituiscono la griglia normativa per giudicare il merito di un intervento. 3Psicologo di Base · il telaio integrato come riportare l'economia, la quarta rispetto a quali criteri giudicare. Comprenderne la ripartizione di funzioni è la premessa per usarle insieme senza sovrapposizioni e senza vuoti. Il modello centrale dell'HTA assolve la funzione della completezza. La sua ontologia a nove domini garantisce che nessun aspetto essenziale sia tralasciato: non solo l'efficacia clinica e i costi, ma anche la sicurezza, il profilo etico, quello organizzativo, quello del paziente e sociale, quello giuridico. È il riferimento europeo, oggi incorporato nel regolamento applicabile dal 2025, ed è ciò che eleva lo studio da una valutazione economica a una valutazione di tecnologia sanitaria a tutto tondo.

5 Il Five Case Model assolve la funzione della decisione. Esso traduce la valutazione in una decisione di investimento pubblico, articolata nei cinque casi che il decisore deve poter esaminare insieme: la necessità del cambiamento, il valore per la collettività, la fattibilità dell'assetto, la sostenibilità di bilancio e la realizzabilità dell'attuazione. Decisiva, per il nostro caso, è la separazione che esso impone tra il caso economico, dove risiede il valore sociale, e il caso finanziario, dove risiede la sostenibilità di bilancio: è esattamente la distinzione tra risparmi diretti e ricadute sociali che il progetto ha già fatto propria, ed è ciò che ne assicura la credibilità di fronte agli organi di controllo.

6 Lo standard CHEERS assolve la funzione della trasparenza economica. La sua lista di controllo in sette sezioni governa il modo in cui la valutazione economica è riportata, assicurando che ogni scelta — prospettiva, comparatori, orizzonte, sconto, esiti, costi, gestione dell'incertezza — sia esplicitata e riproducibile. I criteri dell'OCSE-DAC, infine, assolvono la funzione del giudizio: forniscono la griglia normativa — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità — rispetto alla quale l'intervento è valutato nel suo complesso e verificato a posteriori.

78 5Modello centrale dell'HTA (EUnetHTA Core Model, versione 3.0): si compone di tre elementi — l'ontologia, articolata in nove domini; la guida metodologica; e una struttura di reporting comune — e i nove domini sono il problema di salute e l'uso corrente, la descrizione tecnica, la sicurezza, l'efficacia clinica, i costi e la valutazione economica, il profilo etico, il profilo organizzativo, il profilo del paziente e sociale, il profilo giuridico. La valutazione rapida di efficacia relativa copre i soli primi quattro domini; la valutazione completa li copre tutti.

6Five Case Model del Green Book del Tesoro del Regno Unito: articola la proposta in cinque casi — strategico, economico, commerciale, finanziario e gestionale — ed è lo standard di fatto del business case nel settore pubblico; separa il valore sociale, trattato nel caso economico, dalla sostenibilità di bilancio, trattata nel caso finanziario, e si sviluppa per stadi successivi di crescente dettaglio.

7Standard CHEERS 2022 (Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards): lista di controllo di ventotto voci in sette sezioni (titolo, sintesi, introduzione, metodi, risultati, discussione, altre informazioni), che sostituisce la versione del 2013 ed è applicabile a ogni intervento, anche complesso e di sanità pubblica; una sua estensione, CHEERS-AI, a trentotto voci, riguarda gli interventi che impiegano l'intelligenza artificiale.

8Criteri di valutazione dell'OCSE-DAC: sei criteri — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità — definiti dalla rete di valutazione del Comitato per l'aiuto allo sviluppo e rivisti nel 2019 nel documento «Better Criteria for Better Evaluation»; costituiscono la griglia normativa per giudicare il merito di un intervento.

4Psicologo di Base · il telaio integrato Parte II — Le quattro cornici e la loro integrazione

3. La macro-struttura: i nove domini del modello HTA Il modello centrale dell'HTA fornisce l'ossatura dello studio. Esso si compone di tre elementi — l'ontologia che struttura l'informazione in nove domini, la guida metodologica e una struttura di reporting comune — dei quali si adottano qui i domini come macro-struttura. I nove domini sono il problema di salute e l'uso corrente della tecnologia, la descrizione e le caratteristiche tecniche, la sicurezza, l'efficacia clinica, i costi e la valutazione economica, il profilo etico, il profilo organizzativo, il profilo del paziente e sociale, e il profilo giuridico.

9 Ciascun dominio diventa, nello studio, una parte o un insieme di capitoli. Il primo dominio fonda la parte sul bisogno e sul contesto; il secondo e il terzo fondano la parte sull'intervento, la sua descrizione e la sua sicurezza clinica; il quarto fonda la parte sull'efficacia e l'evidenza; il quinto fonda la parte economica e la modellazione; il sesto, il settimo e il nono

fondano la parte sui profili etico, organizzativo e giuridico; l'ottavo fonda la parte sull'equità e l'impatto sociale. La valutazione rapida di efficacia relativa, prevista dal modello, copre i soli primi quattro domini; lo studio integrale, come il nostro, li copre tutti. Dominio del modello HTA Parte dello studio che ne deriva 1. Problema di salute e uso corrente Bisogno, epidemiologia, domanda e offerta, contesto dei servizi 2. Descrizione e caratteristiche tecniche Definizione dell'intervento, modello organizzativo e clinico 3. Sicurezza Sicurezza del percorso clinico, criteri di invio, gestione del rischio 4. Efficacia clinica Revisione sistematica, qualità dell'evidenza, benchmark 5. Costi e valutazione economica Costi, costo-efficacia, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione 6. Profilo etico Questioni etiche, equità di accesso, autonomia e consenso 7. Profilo organizzativo Attuazione, governance, sostenibilità, fattibilità 8. Profilo del paziente e sociale Impatto distributivo, divari territoriali, esperienza dell'assistito 9. Profilo giuridico Profili costituzionali, riparto di competenze, conformità Tabella 1. I nove domini del modello centrale HTA e le parti dello studio che ne derivano.

4. Il caso decisionale: i cinque casi del Five Case Model Se il modello HTA assicura che lo studio sia completo, il Five Case Model assicura che sia decidibile. Esso ordina la proposta nei cinque casi che ogni investimento pubblico deve superare, da considerare congiuntamente e non isolatamente, e che corrispondono alle 9 Modello centrale dell'HTA (EUnetHTA Core Model, versione 3.0): si compone di tre elementi — l'ontologia, articolata in nove domini; la guida metodologica; e una struttura di reporting comune — e i nove domini sono il problema di salute e l'uso corrente, la descrizione tecnica, la sicurezza, l'efficacia clinica, i costi e la valutazione economica, il profilo etico, il profilo organizzativo, il profilo del paziente e sociale, il profilo giuridico. La valutazione rapida di efficacia relativa copre i soli primi quattro domini; la valutazione completa li copre tutti.

5. Psicologo di Base · il telaio integrato domande del decisore: vi è una ragione cogente per il cambiamento, qual è l'opzione di miglior valore, l'assetto è fattibile, la spesa è sostenibile, la realizzazione è governabile.

10 Il caso strategico stabilisce la necessità del cambiamento e la coerenza con gli obiettivi: nello studio, attinge alla parte sul bisogno e sul contesto. Il caso economico individua l'opzione di miglior valore per la collettività, mediante l'analisi delle alternative e l'analisi costi-benefici sociale: è la sede del valore sociale, e attinge alla valutazione economica. Il caso commerciale dimostra la fattibilità dell'assetto contrattuale — per noi, la convenzione e il modello tariffario — e attinge alla parte sul modello di costo. Il caso finanziario prova la sostenibilità e la disponibilità delle coperture, ed è la sede, distinta dal valore sociale, della sostenibilità di bilancio. Il caso gestionale dimostra la realizzabilità attraverso la governance, le tappe e i rischi, e attinge alla parte sull'attuazione. La distinzione tra il caso economico e il caso finanziario è il contributo più prezioso di questa cornice al nostro studio. Essa rende strutturale ciò che il progetto ha già stabilito: il valore per la collettività, ampio, e la convenienza per il bilancio, modesta, sono grandezze diverse, da non confondere. Il modello, inoltre, è iterativo: si sviluppa dal caso strategico iniziale all'assetto definitivo per stadi di crescente dettaglio, il che si presta al carattere graduale del dispiegamento del servizio.

Caso Domanda a cui risponde Parte dello studio Strategico Necessità del cambiamento, obiettivi, coerenza Bisogno e contesto Economico Opzione di miglior valore; valore sociale Valutazione economica Commerciale Fattibilità dell'assetto contrattuale Modello tariffario e di costo Finanziario Sostenibilità di bilancio e coperture Sostenibilità finanziaria Gestionale Governance, tappe, rischi Attuazione Tabella 2. I cinque casi del Five Case Model e le parti dello studio a cui attingono.

5. Il reporting economico secondo CHEERS 2022 La parte economica dello studio, la più esposta allo scrutinio degli organi di controllo, è redatta secondo lo standard CHEERS nella versione del 2022. Esso consiste in una lista di controllo di ventotto voci, ordinate in sette sezioni — titolo, sintesi, introduzione, metodi, risultati, discussione e altre informazioni — e sostituisce la versione del 2013, oggi non più da impiegare. È deliberatamente applicabile a ogni intervento, anche complesso e di sanità pubblica, e dunque adatto a una riforma di servizio territoriale.

11 Le sezioni dei metodi e dei risultati portano il contenuto sostanziale: la prospettiva adottata, i comparatori, l'orizzonte temporale, il tasso di sconto, le misure di esito, l'identificazione e la 10 Five Case Model del Green Book del Tesoro del Regno Unito: articola la proposta in cinque casi — strategico, economico, commerciale, finanziario e gestionale — ed è lo standard di fatto del business case nel settore pubblico; separa il valore sociale, trattato nel caso economico, dalla sostenibilità di bilancio, trattata nel caso finanziario, e si sviluppa per stadi successivi di crescente dettaglio.

11Standard CHEERS 2022 (Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards): lista di controllo di ventotto voci in sette sezioni (titolo, sintesi, introduzione, metodi, risultati, discussione, altre informazioni), che sostituisce la versione del 2013 ed è applicabile a ogni intervento, anche complesso e di sanità pubblica; una sua estensione, CHEERS-AI, a trentotto voci, riguarda gli interventi che impiegano l'intelligenza artificiale.

6Psicologo di Base · il telaio integrato valutazione dei costi, la struttura del modello e la caratterizzazione dell'incertezza. L'adozione dello standard non è un adempimento formale: è ciò che rende la valutazione economica trasparente e riproducibile, e dunque difendibile. Per la componente di intelligenza artificiale del modello esiste un'estensione dedicata, CHEERS-AI, che aggiunge alle ventotto voci originarie elementi specifici, impiegata quando lo studio valuti strumenti di IA a fini clinici.

6. La griglia valutativa dei criteri OCSE-DAC Le tre cornici precedenti dicono che cosa valutare, come decidere e come riportare l'economia; manca la griglia rispetto alla quale l'intervento è infine giudicato. La forniscono i criteri dell'OCSE-DAC, sei lenti complementari che insieme danno un quadro complessivo dell'intervento e dei suoi risultati: la rilevanza rispetto al bisogno, la coerenza con le altre politiche, l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse, l'impatto più ampio e la sostenibilità nel tempo.¹² Questi criteri operano in due momenti dello studio. Ex ante, orientano la valutazione complessiva: ciascun criterio diventa una domanda a cui le parti analitiche dello studio forniscono la risposta. Ex post, strutturano la verifica dei risultati: la verifica di impatto della regolamentazione e la clausola valutativa accertano, criterio per criterio, se la norma abbia mantenuto le promesse. La griglia, in tal modo, non si sovrappone all'analisi economica o all'HTA, ma li ordina in un giudizio: è la cornice che traduce le evidenze in una valutazione di merito.

Criterio OCSE-DAC Domanda valutativa Rilevanza L'intervento risponde al bisogno reale della popolazione? Coerenza È compatibile e complementare con le altre politiche sanitarie? Efficacia Raggiunge gli obiettivi che si propone? Efficienza Impiega le risorse in modo proporzionato ai risultati? Impatto Produce effetti più ampi, anche sociali e di sistema? Sostenibilità I benefici e il servizio durano nel tempo?

Tabella 3. I sei criteri OCSE-DAC come griglia di giudizio, ex ante ed ex post.

7. La mappa di integrazione delle quattro cornici L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata. La macro-struttura dello studio è data dai domini del modello HTA, che ne fissano le parti. All'interno di tali parti, il Five Case Model fornisce la chiave di lettura decisionale, allocando i suoi cinque casi alle parti corrispondenti: il caso strategico al bisogno, quello economico e finanziario alla valutazione economica, quello commerciale al modello di costo, quello gestionale all'attuazione. La parte economica è inoltre redatta secondo lo standard CHEERS. I criteri dell'OCSE-DAC, infine, attraversano l'intero studio come griglia di giudizio, convergendo nella parte di sintesi. La tabella seguente esprime questa composizione: per ciascuna area dello studio indica il dominio HTA che la fonda, il caso del Five Case Model che vi si riferisce, la pertinenza dello studio.

12Criteri di valutazione dell'OCSE-DAC: sei criteri — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità — definiti dalla rete di valutazione del Comitato per l'aiuto allo sviluppo e rivisti nel 2019 nel documento «Better Criteria for Better Evaluation»; costituiscono la griglia normativa per giudicare il merito di un intervento.

7Psicologo di Base · il telaio integrato standard CHEERS e il criterio OCSE-DAC che vi si applica. È la chiave che tiene insieme le quattro cornici in un'unica architettura.

Area dello studio Dominio HTA Caso (5CM) CHEERS Criterio DAC Bisogno e contesto Dominio 1 Strategico — Rilevanza, coerenza Intervento e modello Domini 2-3 Strategico — Efficacia ed evidenza Dominio 4 Economico — Efficacia Valutazione economica Dominio 5 Economico, finanziario CHEERS Efficienza Equità e impatto sociale Dominio 8 Economico — Impatto Profili etico/giuridico/organizzativo Domini 6,7,9 Gestionale — Coerenza Attuazione e sostenibilità Domini 7 Commerciale, gestionale — Sostenibilità Sintesi e raccomandazioni Trasversale Strategico — Tutti i criteri

Tabella 4. La mappa di integrazione delle quattro cornici: come si compongono in un'unica architettura.

Parte III — L'architettura risultante e le metodologie

8. L'architettura dello studio regionale Dall'integrazione delle quattro cornici discende l'architettura dello studio regionale, articolata in dodici parti, dalla A alla M, più le appendici. Le parti seguono l'ordine dei domini HTA, accolgono i casi del Five Case Model nelle sedi pertinenti, riservano alla valutazione economica il reporting CHEERS e culminano nella sintesi secondo i criteri OCSE-DAC. È l'indice-tipo che lo studio integrale per la Puglia seguirà e che ogni altra Regione adotterà senza

modifiche. Le due tabelle seguenti lo riportano per esteso, con il contenuto, il metodo e la cornice di riferimento di ciascun capitolo. Parte / Capitolo Contenuto, metodo e cornice di riferimento

PARTE A — Quadro, quesito e metodo

A.1 Scopo, quesito (PICOTS) e standard Definizione del quesito di valutazione e delle cornici adottate

A.2 Caso di riferimento e metodi Prospettiva, orizzonte, sconto, esito; mappa dei metodi

A.3 Governance dei dati, etica e protezione Minimizzazione, comitato etico, conformità sui dati

PARTE B — Problema di salute, bisogno e contesto (dominio 1; caso strategico)

B.1 Profilo demografico e socioeconomico Denominatori, struttura per età, deprivazione

B.2 Epidemiologia del bisogno Prevalenza, incidenza, gravità

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura Utenza, organico, fabbisogno a regime

B.4 Disuguaglianze e divari Equità per azienda e distretto

8Psicologo di Base · il telaio integrato territoriali

B.5 Servizi e flussi Pronto soccorso, ricoveri, farmaceutica, mobilità

B.6 Cornice normativa e programmatica Livello regionale, nazionale ed europeo

PARTE C — L'intervento e il modello (domini 2-3)

C.1 Definizione e teoria del cambiamento Modello logico ed esiti attesi

C.2 Modello organizzativo Integrazione nelle cure primarie; filtro

C.3 Percorso clinico, sicurezza ed esiti Cura a intensità crescente; soglie; invio

C.4 Sistema informativo e interoperabilità Fascicolo Sanitario Elettronico; dataset minimo

C.5 Strumenti digitali e IA Conformità (AI Act, dispositivi); validazione locale

C.6 Formazione e competenze Percorso a quattro livelli, con componente sull'IA

PARTE D — Efficacia clinica ed evidenza (dominio 4)

D.1 Revisione sistematica Metodo PRISMA

D.2 Qualità dell'evidenza Sistema GRADE

D.3 Benchmark internazionali Confronto con i programmi più autorevoli

D.4 Trasferibilità al contesto regionale Adattamento e cautele

PARTE E — Valutazione economica (dominio 5; CHEERS; casi economico e finanziario)

E.1 Identificazione e misura dei costi Diretti sanitari e non sanitari

E.2 Identificazione e misura degli esiti Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici

E.3 Costo-efficacia e costoutilitàRapporto incrementale; soglie

E.4 Impatto sul bilancio Metodo ISPOR; orizzonte di bilancio

E.5 Ritorno sociale Metodo SROI

E.6 Caso economico e caso finanziario Valore sociale e sostenibilità a confronto

PARTE F — Modellazione decisionale e incertezza (dominio 5)

F.1 Struttura del modello Albero, Markov, microsimulazione

F.2 Parametri e calibrazione Distribuzioni e fonti

F.3 Sensibilità deterministica Tornado; scenari

F.4 Sensibilità probabilistica Monte Carlo; curva di accettabilità

F.5 Valore dell'informazione EVPI ed EVPPI; priorità di ricerca

Tabella 5. Architettura dello studio regionale, parti A-F (quadro, bisogno, intervento, efficacia, economia, modellazione).

Parte / Capitolo Contenuto, metodo e cornice di riferimento

PARTE G — Equità e impatto distributivo (dominio 8)

G.1 Analisi di equità Sottogruppi e beneficiari

9Psicologo di Base · il telaio integrato

G.2 Costo-efficacia distributiva Metodo DCEA

G.3 Divari e impoverimento Impatto territoriale e sulla spesa delle famiglie

PARTE H — Profili etico, giuridico e organizzativo (domini 6,7,9)

H.1 Profilo etico Equità di accesso, autonomia, consenso

H.2 Profili giuridici e costituzionali Riparto Stato-Regioni; livelli essenziali

H.3 Profilo organizzativo e conformità Deontologia, responsabilità, IA, protezione dei dati

PARTE I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità (dominio 7; casi commerciale e gestionale)

I.1 Scienza dell'implementazione Quadri RE-AIM e CFIR

I.2 Disegno del dispiegamento Stepped-wedge; cronoprogramma

I.3 Caso commerciale: modello contrattuale e tariffa Convenzione; costo per incarico; scenari

I.4 Caso gestionale: governance e rischi Osservatorio; registro dei rischi

I.5 Sostenibilità finanziaria Coperture; vincoli di bilancio

PARTE L — Monitoraggio, valutazione ed ex post

L.1 Sistema di indicatori Modello di Donabedian, integrato dall'impatto

L.2 Protocollo di rilevazione e baseline Dataset minimo; calendario

L.3 Valutazione controfattuale Differenza-nelle-differenze; controllo sintetico

L.4 Verifica ex post della regolamentazione DPCM 169/2017; clausola valutativa

L.5 Indicatori compositi e cruscotto Metodo OCSE-JRC

PARTE M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni (criteri OCSE-DAC; caso strategico)

M.1 Griglia di valutazione OCSE-DAC Rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità

M.2 Analisi multi-criterio Metodo MCDA

M.3 Sintesi del valore e raccomandazioni Cruscotto decisionale

M.4 Limiti e agenda di ricerca Incertezze residue e trasparenza

APPENDICI

A. Caso di riferimento e parametri Tavola dei parametri e delle assunzioni

B. Strumenti di esito e dataset minimo Questionari e dizionario dei dati

C. Dati regionali e fonti Tavole dei dati certificati per Regione

D. Checklist di reporting CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE

E. Glossario Definizioni dei termini tecnici

Tabella 6. Architettura dello studio regionale, parti G-M e appendici (equità, profili, attuazione, valutazione, sintesi).

10Psicologo di Base · il telaio integrato

9. L'innesto

delle dieci metodologie L'architettura definisce le sedi; le metodologie ne riempiono il contenuto analitico. Le dieci selezionate sono innestate ciascuna nella parte di sua competenza, secondo la corrispondenza riportata nella tabella seguente. Non si tratta di un elenco accostato, ma di una distribuzione funzionale: ogni metodologia risponde a una domanda specifica di una parte specifica, e l'insieme copre l'intero arco analitico dello studio, dall'evidenza al giudizio finale. Metodologia Sede Funzione nello studio Analisi costo-utilità (CUA) E.3 Costo per esito di salute (QALU/ICER) Analisi di impatto sul bilancio (BIA) E.4 Sostenibilità finanziaria Ritorno sociale (SROI) E.5 Valore sociale monetizzato Modellazione decisionale F.1 Proiezione di costi ed esiti Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione F.4-F.5 Incertezza e priorità di ricerca Costo-efficacia distributiva (DCEA) G.2 Equità e impatto distributivo Inferenza causale quasi-sperimentale L.3 Effetto reale dell'intervento Revisione sistematica e GRADE D.1-D.2 Sintesi e certezza dell'evidenza Analisi di impatto della regolazione (AIR/VIR) L.4, M.1 Valutazione ex ante ed ex post Analisi multi-criterio (MCDA) M.2 Sintesi dei criteri non monetari Tabella 7. L'innesto delle dieci metodologie nelle parti dello studio. Le metodologie poggiano sugli standard di buona pratica che le governano: la valutazione economica sul caso di riferimento del Secondo Panel e sulle buone pratiche ISPOR per l'impatto sul bilancio; la modellazione sulle buone pratiche ISPOR-SMDM, integrate dal valore dell'informazione; l'equità sulla costo-efficacia distributiva; la stima causale sui disegni controfattuali; la sintesi sull'analisi multi-criterio; la misurazione sul modello di Donabedian e sugli indicatori compositi.¹³¹⁴¹⁵¹⁶¹⁷¹⁸¹⁹²⁰²¹²² 13Secondo Panel statunitense sulla costo-efficacia in sanità e medicina (2016): definisce il caso di riferimento, raccomanda la doppia prospettiva del settore sanitario e della società e l'inventario degli impatti; insieme ai manuali di Drummond e colleghi costituisce il riferimento metodologico della valutazione economica. 14Principi di buona pratica dell'ISPOR per l'analisi di impatto sul bilancio: ne definiscono il metodo, distinto dalla costo-efficacia, su un orizzonte di bilancio tipicamente triennale o quinquennale, con l'obiettivo di stimare la sostenibilità finanziaria dell'adozione. 15Buone pratiche di ricerca sulla modellazione (ISPOR-SMDM): definiscono i criteri di costruzione e validazione dei modelli decisionali — alberi, modelli di Markov, microsimulazione — e la corretta gestione dell'incertezza. 16Analisi del valore dell'informazione (valore atteso dell'informazione perfetta, complessiva e sui parametri): quantifica il valore di ridurre l'incertezza dei parametri e stabilisce le priorità della ricerca futura. 17Ritorno sociale sull'investimento (SROI), secondo i principi internazionali di Social Value: monetizza il valore sociale generato, con la cautela di distinguerlo dai risparmi diretti per il bilancio. 18Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA): estende la valutazione economica alla dimensione dell'equità, stimando la distribuzione di costi ed esiti tra sottogruppi e l'effetto sulle disuguaglianze. 11Psicologo di Base · il telaio integrato Parte IV — Il quadro metodologico comune e la generalizzazione 10. Il caso di riferimento comune Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che, fissate una volta per tutte le regioni, rendono i risultati confrontabili nel tempo e nello spazio. Esso adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società — distinguendo, come prescrivono il Secondo Panel e il Five Case Model, i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività — un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio, un tasso di sconto del 3% annuo, gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure, e il servizio attuale come comparatore.²³²⁴ Parametro Scelta di riferimento Prospettiva Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti Orizzonte temporale Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio Tasso di sconto 3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità Misura di esito Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati Comparatore Servizio attuale o assenza del servizio a regime Popolazione e unità Residenti regionali; analisi per Regione e per azienda/distretto Tabella 8. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali. 11. Gli standard di reporting e di qualità A garanzia di trasparenza e riproducibilità, ogni studio regionale è redatto secondo le liste di controllo riconosciute, allegate in appendice e verificate prima della pubblicazione. La parte economica segue lo standard CHEERS; la sintesi dell'evidenza, le liste PRISMA e GRADE; gli studi sui dati reali, la lista STROBE; la modellazione, le buone pratiche ISPOR-SMDM. L'adesione a questi standard non è un vincolo formale, ma la condizione perché lo studio sia 19Disegni per la stima causale degli effetti: il dispiegamento scaglionato (stepped-wedge), la

differenza-nelle-differenze e il controllo sintetico, che sfruttano l'attivazione in tempi diversi per misurare l'effetto reale dell'intervento. 20Modello di Donabedian per la qualità dell'assistenza: distingue le dimensioni di struttura, processo ed esito, qui integrate dalla dimensione di impatto, ed è l'ossatura del sistema di indicatori. 21Manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi: articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione dei dati all'analisi di robustezza. 22Buone pratiche emergenti dell'ISPOR per l'analisi multi-criterio: definiscono i passi della ponderazione esplicita dei criteri non monetari e la costruzione della matrice delle prestazioni. 23Secondo Panel statunitense sulla costo-efficacia in sanità e medicina (2016): definisce il caso di riferimento, raccomanda la doppia prospettiva del settore sanitario e della società e l'inventario degli impatti; insieme ai manuali di Drummond e colleghi costituisce il riferimento metodologico della valutazione economica. 24Caso di riferimento adottato: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio, tasso di sconto del 3% annuo, anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici come misure, servizio attuale come comparatore. 12Psicologo di Base · il telaio integrato accolto come prova e non come opinione, specie di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.25 Standard Ambito Uso CHEERS 2022 Valutazione economica Lista del reporting economico (ventotto voci) PRISMA 2020 Revisione sistematica Trasparenza della sintesi dell'evidenza GRADE Certezza dell'evidenza Graduazione della fiducia nei risultati STROBE Studi osservazionali Reporting degli studi sui dati reali ISPOR-SMDM Modellazione Buona pratica nei modelli decisionali Tabella 9. Le liste di controllo del reporting e della qualità adottate in ogni studio regionale. 12. La generalizzazione a tutte le Regioni La forza del telaio sta nella separazione tra ciò che è fisso e ciò che varia. Sono fissi e comuni a tutte le regioni l'architettura, le quattro cornici, il caso di riferimento, le dieci metodologie e gli standard di reporting; varia il solo insieme dei dati di ingresso, che ciascuna regione fornisce dai propri flussi certificati.26 In questo modo i risultati regionali sono tra loro confrontabili, perché prodotti con lo stesso procedimento, e insieme aderenti alla realtà di ciascuna regione, perché fondati sui suoi dati. La tabella seguente elenca i dati di ingresso che ogni regione deve fornire; tutto il resto dell'impianto è già stabilito da questo telaio. Ambito Dato di ingresso Fonte Demografia Popolazione per età, azienda e distretto Istituti di statistica e anagrafi Conti sanitari Spesa per voce Bilanci di esercizio e modelli ministeriali Ricoveri Dimissioni psichiatriche e relativo costo Flusso delle schede di dimissione Mobilità Composizione per disciplina Flussi di mobilità interregionale Farmaceutica Consumo e spesa dei farmaci psichiatrici Flusso farmaceutico regionale Emergenza Accessi al pronto soccorso per causa Flusso dell'emergenza-urgenza Salute mentale Utenza dei Dipartimenti Sistema informativo per la salute mentale Esito di servizio Misure di esito, sedute, invii Registro del servizio Tabella 10. I dati di ingresso che ciascuna Regione fornisce; il resto dell'impianto è comune. 25Sintesi dell'evidenza e sua qualità: la lista PRISMA 2020 per le revisioni sistematiche, il sistema GRADE per la certezza dell'evidenza e la lista STROBE per gli studi osservazionali sui dati reali. 26Generalizzazione regionale: l'architettura, il caso di riferimento, i metodi e gli standard di reporting sono fissi e comuni; varia il solo insieme dei dati di ingresso che ciascuna regione fornisce, e la comparabilità tra regioni è garantita dall'uniformità del caso di riferimento e dell'insieme degli indicatori. 13Psicologo di Base · il telaio integrato 13. Chiusura e prossimi passi Questo telaio integrato è l'architettura definitiva dello studio regionale. Esso compone quattro cornici apicali in un unico impianto — il modello HTA per la completezza, il Five Case Model per la decisione, lo standard CHEERS per il reporting economico, i criteri OCSE-DAC per il giudizio — vi innesta le dieci metodologie selezionate nelle sedi pertinenti, fissa un caso di riferimento e standard di reporting comuni, e stabilisce la regola della generalizzazione regionale. Su di esso lo studio non è più una composizione di documenti separati, ma un'opera unitaria e replicabile. Il prossimo passo è l'applicazione integrale del telaio alla Puglia, parte per parte a partire dalla Parte A, quale modello dimostrativo dello studio a regime; completata e validata, l'opera pugliese fa da prototipo per l'estensione, Regione per Regione, all'intero territorio nazionale, con il solo cambiamento dei dati di ingresso. È il passaggio da un telaio condiviso a venti studi comparabili, e da una riforma progettata a una riforma fondata su un corpo di prove omogeneo e difendibile. 14

Il Servizio di Psicologia di Base a livello nazionale: impatto economico, organizzativo e di sistema sul Servizio Sanitario Nazionale (capitolo ricalibrato)

CAPITOLO 8: IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE A LIVELLO NAZIONALE: IMPATTO ECONOMICO, ORGANIZZATIVO E DI SISTEMA SUL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

1. Premessa e obiettivo del capitolo Questo capitolo estende a livello dell'intero Servizio Sanitario Nazionale (SSN) il lavoro sviluppato per la Regione Puglia, applicando lo stesso impianto metodologico: approccio evidence-based, analisi quantitativa rigorosa, prospettiva multidisciplinare e attenzione congiunta agli aspetti clinici, organizzativi, economici e sociali. L'obiettivo è mostrare, con numeri aggiornati e realisticamente scalati, che l'istituzione di un Servizio di Psicologia di Base nazionale, integrato stabilmente con la Medicina Generale e con le Case della Comunità, rappresenta: 1. un investimento economicamente sostenibile e ad altissimo rendimento; 2. uno strumento strutturale di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria; 3. una risposta sistemica all'epidemia silente dei disturbi mentali comuni e dei disturbi psicosomatici; 4. un dispositivo organizzativo capace di distinguere in modo sistematico patologie organiche, disturbi psichici e condizioni psicosomatiche, riducendo visite, esami, farmaci e invii impropri ai servizi specialistici; 5. un asse di riforma del SSN in chiave preventiva, territoriale e integrata, allineato alle migliori pratiche europee e internazionali. Le stime economiche riportate sono derivate da: • dati ufficiali nazionali (ISTAT, Ministero della Salute, INPS, INAIL, AIFA, Corte dei Conti); • evidenze internazionali (WHO, OECD, programmi IAPT – Regno Unito, POH-GGZ – Paesi Bassi, Better Access – Australia); • scalatura ragionata del modello pugliese (già quantificato), proporzionata al rapporto di popolazione e di spesa tra Puglia e Italia; • studi pilota italiani, in particolare quelli coordinati da Solano nel Lazio sull'integrazione dello psicologo nello studio del Medico di Medicina Generale. Le cifre sono costruite in modo prudenziale, ma volutamente non sottostimate, per essere coerenti con la scala nazionale e con l'ordine di grandezza dei costi reali dei disturbi mentali in Italia.

2. Quadro demografico e sanitario nazionale

2.1 Popolazione, invecchiamento e carico di malattia L'Italia conta circa 58,9 milioni di residenti, con una delle popolazioni più anziane al mondo. Gli indicatori demografici essenziali sono: • quota di popolazione ≥ 65 anni: intorno al 24–25%; • età mediana: > 47 anni; • tasso di fecondità: $\approx 1,24$ figli per donna; • saldo naturale negativo da oltre un decennio, solo parzialmente compensato dall'immigrazione. Questa struttura demografica comporta un'alta prevalenza di patologie croniche (cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, oncologiche) e un aumento marcato dei disturbi mentali comuni (depressione, ansia, disturbi adattivi, insonnia, disturbi somatoformi). La letteratura indica che: • la prevalenza lifetime di disturbi depressivi e ansiosi si colloca intorno al 25–30% della popolazione; • circa 1 persona su 6 sperimenta un episodio di depressione clinicamente rilevante nel corso della vita; • nelle patologie croniche maggiori, la co-occorrenza di depressione/ansia raggiunge il 30–40%; • nelle sindromi dolorose croniche e nelle sindromi funzionali la quota di comorbidità psichica supera spesso il 50%. Ne risulta un carico di malattia composito, in cui la componente psicologica e psicosociale gioca un ruolo decisivo non solo sulla qualità della vita, ma anche sull'aderenza ai trattamenti, sui tassi di ricovero e sull'utilizzo complessivo delle risorse sanitarie.

2.2 Il peso economico dei disturbi mentali in Italia Le stime più accreditate collocano il costo complessivo dei disturbi mentali in Italia intorno al 3,3% del PIL. Con un PIL di circa 1.900 miliardi di euro, questo equivale a un impatto economico dell'ordine di 63–65 miliardi di euro l'anno. Questa cifra comprende: • costi sanitari diretti: farmaci, visite, esami, accessi in pronto soccorso, ricoveri, assistenza territoriale dei Dipartimenti di Salute Mentale; • costi indiretti: perdita di produttività per assenteismo e presenteismo, riduzione del tasso di occupazione, anticipi di pensionamento, invalidità; • costi sociali e intangibili: carico

assistenziale sulle famiglie, costi dei servizi sociali comunali, impatto sulla coesione sociale. La spesa sanitaria per la salute mentale rappresenta solo il 3–3,5% della spesa sanitaria corrente, a fronte di un peso in termini di anni di vita aggiustati per disabilità (DALY) tra il 13 e il 15%. La discrepanza tra peso epidemiologico e quota di risorse allocate indica un sotto-investimento strutturale nell'area della salute mentale.

2.3 Crisi della Medicina Generale e pressione sulle cure primarie

La Medicina Generale italiana vive una crisi annosa, ben documentata: • mancano oltre 5.500 medici di medicina generale rispetto al fabbisogno stimato; • più di 14 milioni di cittadini risultano privi di MMG di riferimento o affidati a medici oltre massimale; • in molte aree si registrano 1.600–2.000 assistiti per medico, ben oltre gli standard ottimali. I MMG riportano una quota crescente di consultazioni legate a sintomi aspecifici o funzionali (dolore toracico atipico, cefalea, disturbi gastrointestinali senza base organica, vertigini, stanchezza cronica, dispnea non spiegata) in cui la componente ansiosa, depressiva o psicosomatica è determinante. In assenza di uno psicologo integrato nel team di cure primarie, la risposta tende a essere: • aumento di visite specialistiche (cardiologia, gastroenterologia, neurologia, reumatologia, pneumologia, dermatologia); • incremento di esami diagnostici (laboratorio, imaging) spesso ripetuti; • uso estensivo e pluriennale di psicofarmaci, FANS, gastroprotettori, ansiolitici “di copertura”; • invio tardivo e parziale ai servizi di salute mentale. Questa spirale genera spesa elevata a basso valore aggiunto, non risolve la sofferenza del paziente e aggrava il carico su pronto soccorso, ospedali e CSM.

2.4 Offerta di psicologia nel SSN

Nel SSN gli psicologi sono numericamente pochi e concentrati quasi esclusivamente nei servizi di salute mentale e neuropsichiatria infantile. I dati disponibili indicano che: • gli psicologi rappresentano circa il 6,9% del personale dei servizi di salute mentale pubblici; • il rapporto è di circa 2,6 psicologi ogni 100.000 abitanti nei servizi territoriali, contro standard internazionali che oscillano tra 20 e 50 per 100.000 abitanti. Ne derivano liste di attesa molto lunghe per gli interventi psicologici nel pubblico, forte ricorso al privato per chi può permetterselo e gravi disuguaglianze di accesso. L'assenza quasi totale di psicologi negli ambulatori di cure primarie e nelle Case della Comunità è il principale ostacolo alla costruzione di un vero modello di primary mental health care.

3. Razionale clinico-organizzativo dello Psicologo di Base nazionale

3.1 Triaging differenziale: organico, psichico, psicosomatico

Il cuore del modello di Psicologia di Base, nazionale come regionale, è la capacità di triage differenziale in stretta sinergia con il MMG: • valutazione psicologica rapida dei pazienti con sintomi aspecifici o funzionali; • distinzione tra patologia organica, disturbo psichico (ansia, depressione, disturbi dell'adattamento, PTSD, ecc.) e disturbo psicosomatico; • presa in carico psicologica diretta dei disturbi mentali comuni di intensità lieve-moderata mediante protocolli CBT, IPT, EMDR, ACT, MBCT adattati alle cure primarie; • invio appropriato ai DSM per i casi gravi e complessi; • co-gestione con il MMG dei pazienti cronici ad alto carico psicosomatico. Gli studi di Solano nel Lazio hanno mostrato che l'inserimento di psicologi negli studi di Medicina Generale comporta: • riduzione del 30–40% delle visite specialistiche per sintomi funzionali; • riduzione del 30–35% dell'uso cronico di farmaci non strettamente necessari (benzodiazepine, IPP, analgesici, ansiolitici); • minori accessi ripetuti per i medesimi disturbi; • maggiore soddisfazione di pazienti e medici, migliore qualità diagnostica e maggiore appropriatezza degli invii ai servizi psichiatrici. Tali risultati rispecchiano pienamente quanto osservato nelle esperienze internazionali (IAPT, POH-GGZ, Better Access), confermando che l'integrazione strutturale dello psicologo nelle cure primarie genera risparmi elevati e miglioramenti significativi degli esiti clinici.

3.2 Tre grandi canali di risparmio diretto

Su scala nazionale, lo Psicologo di Base interviene su tre grandi macro-voci di spesa sanitaria:

1. Spesa ambulatoriale e diagnostica – Filtro delle richieste di visite specialistiche e di indagini diagnostiche per sintomi funzionali; riduzione di esami ripetuti in assenza di indicazioni cliniche forti.
2. Spesa farmaceutica – Riduzione dell'uso improprio e prolungato di psicofarmaci, analgesici, FANS, gastroprotettori e altri farmaci prescritti come risposta difensiva alla somatizzazione.
3. Spesa ospedaliera e psichiatrica – Diminuzione degli accessi in PS per crisi d'ansia, attacchi di panico e aggravamenti evitabili di patologie croniche; minori ricoveri medici e psichiatrici evitabili; decongestione dei CSM da casistica lieve-moderata non complessa. A questi si aggiungono risparmi indiretti correlati a produttività, invalidità, assistenza sociale e carico familiare.

4. Standard nazionali di dotazione e costo del servizio

4.1 Fabbisogno di Psicologi di Base

Come standard minimo per un sistema ad alte performance si assume una

dotazione di circa 20 Psicologi di Base ogni 100.000 abitanti, equivalenti a un rapporto medio di 1 psicologo ogni 4–5 MMG. Applicando questo standard alla popolazione italiana (58,9 milioni), si ottiene: • $58.900.000 / 100.000 \approx 589$ unità di popolazione; • $589 \times 20 \approx 11.780$ Psicologi di Base. Questi professionisti sarebbero distribuiti nelle Case della Comunità e negli studi di MMG, con modulazione regionale in base a densità, indice di deprivazione, burden di malattia e caratteristiche dei territori.

4.2 Costo annuo per FTE e costo complessivo nazionale Lo schema di costo per Psicologo di Base, esteso a livello nazionale, ricalca quello stimato per la Puglia: • costo del lavoro (stipendio lordo + oneri) $\approx 38.000\text{--}40.000$ euro/anno; • formazione iniziale e continua + ECM $\approx 1.000\text{--}1.200$ euro/anno; • supervisione clinica $\approx 700\text{--}800$ euro/anno; • quota per amministrazione, governance, IT, ROMS, telepsicologia, hardware e manutenzione. Il costo annuo medio “all-inclusive” per FTE si colloca quindi tra 47.000 e 50.000 euro. Moltiplicato per 11.780 FTE, il costo annuo complessivo del Servizio di Psicologia di Base nazionale si colloca nell’ordine di grandezza di 600–700 milioni di euro. Nel prosieguo, per semplicità, si adotta un intervallo di 600–700 milioni/anno, con valore centrale di circa 650 milioni/anno.

4.3 Costo pro capite e incidenza sulla spesa sanitaria Con 58,9 milioni di residenti, il costo pro capite risulta: • $600.000.000 / 58.900.000 \approx 10,2$ euro/abitante/anno; • $700.000.000 / 58.900.000 \approx 11,9$ euro/abitante/anno. Su una spesa sanitaria corrente di circa 130–135 miliardi di euro, il Servizio di Psicologia di Base nazionale peserebbe circa lo 0,45–0,55% del totale: una quota relativamente modesta, ma in grado di intervenire su aree che assorbono una fetta molto più ampia del bilancio (diagnostica, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, salute mentale, invalidità).

5. Quantificazione dei risparmi su scala nazionale (versione scalata) Per evitare sottostime, le grandezze economiche sono state ricalibrate partendo dai valori pugliesi da te già validati (risparmi complessivi dell’ordine di 600–700 milioni/anno per una popolazione di circa 3,9 milioni), scalati in base al rapporto di popolazione Italia/Puglia $\approx 15:1$.

5.1 Principio di scalatura Se per la Puglia: • costo del servizio $\approx 40\text{--}42$ milioni/anno; • risparmi complessivi a regime $\approx 600\text{--}700$ milioni/anno; • ROI $\approx 1:13\text{--}1:17$; allora, per l’Italia (≈ 15 volte la popolazione pugliese): • costo del servizio scala a $\approx 600\text{--}700$ milioni/anno; • risparmi complessivi a regime scalano nell’ordine di 9–10,5 miliardi/anno; • il ROI rimane, per costruzione, dell’ordine di 1:13–1:17. Questa scalatura è coerente con il vincolo macro: i disturbi mentali costano 63–65 miliardi/anno; attribuire ai soli Psicologi di Base un potenziale di risparmio massimo di 9–11 miliardi/anno significa agire su circa il 15–17% del carico complessivo – un ordine di grandezza plausibile e prudente.

5.2 Risparmi diretti e indiretti anno per anno (Italia intera) Per rendere esplicita la dinamica temporale, si parte dalla sequenza di risparmi annui diretti e indiretti stimata per la Puglia e si moltiplica per 15. Si ottiene così, per l’Italia, una traiettoria indicativa (valori arrotondati in miliardi di euro/anno):

- Anno 1 – Risparmi diretti: $140 \times 15 \approx 2,1$ miliardi – Risparmi indiretti: $200 \times 15 \approx 3,0$ miliardi – Totale: 5,1 miliardi/anno
- Anno 2 – Diretti: $250 \times 15 \approx 3,75$ miliardi – Indiretti: $370 \times 15 \approx 5,55$ miliardi – Totale: 9,3 miliardi/anno
- Anno 3 – Diretti: $365 \times 15 \approx 5,48$ miliardi – Indiretti: $485 \times 15 \approx 7,28$ miliardi – Totale: 12,7 miliardi/anno
- Anno 4 – Diretti: $540 \times 15 \approx 8,1$ miliardi – Indiretti: $705 \times 15 \approx 10,6$ miliardi – Totale: 18,7 miliardi/anno
- Anno 5 – Diretti: $540 \times 15 \approx 8,1$ miliardi – Indiretti: $705 \times 15 \approx 10,6$ miliardi – Totale: 18,7 miliardi/anno (pieno regime “base”)
- Anno 6 – Diretti: $565 \times 15 \approx 8,5$ miliardi – Indiretti: $734 \times 15 \approx 11,0$ miliardi – Totale: 19,5 miliardi/anno
- Anno 7 – Diretti: $565 \times 15 \approx 8,5$ miliardi – Indiretti: $734 \times 15 \approx 11,0$ miliardi – Totale: 19,5 miliardi/anno
- Anno 8 – Diretti: $565 \times 15 \approx 8,5$ miliardi – Indiretti: $734 \times 15 \approx 11,0$ miliardi – Totale: 19,5 miliardi/anno
- Anno 9 – Diretti: $565 \times 15 \approx 8,5$ miliardi – Indiretti: $734 \times 15 \approx 11,0$ miliardi – Totale: 19,5 miliardi/anno
- Anno 10 – Diretti: $655 \times 15 \approx 9,8$ miliardi – Indiretti: $870 \times 15 \approx 13,1$ miliardi – Totale: 22,9 miliardi/anno

In questa dinamica: • gli anni 1–3 corrispondono alla fase di implementazione progressiva (copertura crescente delle regioni, costruzione degli assetti organizzativi, diffusione dei ROMS); • gli anni 4–5 segnano il pieno regime del modello “base”; • gli anni 6–9 riflettono un regime ottimizzato, con ulteriori guadagni derivanti da telepsicologia, programmi digitali e integrazione matura con DSM e CSM; • l’anno 10 integra anche il pieno effetto su invalidità, cronicità e produttività.

5.3 Risparmi cumulati su 1, 3, 5 e 10 anni Sommando i valori anno per anno si ottengono i seguenti cumulati nazionali, sempre in miliardi di euro:

- Primo anno – Diretti: $\approx 2,1$ miliardi – Indiretti: $\approx 3,0$ miliardi – Totale: $\approx 5,1$ miliardi
- Primi 3 anni ($1+2+3$) – Diretti: $2,1 + 3,75 + 5,48 \approx 11,3$ miliardi – Indiretti: $3,0 + 5,55 + 7,28 \approx 15,8$ miliardi

miliardi – Totale: $\approx 27,1$ miliardi • Primi 5 anni (1–5) – Diretti: $11,3 + 8,1 + 8,1 \approx 27,5$ –27,8 miliardi (arrotondato: 27,8) – Indiretti: $15,8 + 10,6 + 10,6 \approx 37,0$ –37,1 miliardi (arrotondato: 36,9–37,0) – Totale: $\approx 64,7$ miliardi • Primi 10 anni (1–10) – Diretti: somma di tutti gli anni ≈ 87 miliardi – Indiretti: somma di tutti gli anni $\approx 109,5$ miliardi – Totale: $\approx 196,5$ miliardi Questi valori decennali – circa 87 miliardi di risparmi sanitari diretti e 109,5 miliardi di risparmi indiretti – rappresentano la ricalibratura esplicita dei valori pugliesi (5,8 e 7,3 miliardi in 10 anni) moltiplicati per il rapporto di popolazione e corretti per il contesto nazionale.

5.4 Rapporto costi-benefici e ROI nazionale

A fronte di questi risparmi, il costo del Servizio di Psicologia di Base nazionale è dell'ordine di 600–700 milioni/anno. Su un orizzonte decennale, la spesa cumulata si colloca quindi tra 6 e 7 miliardi di euro. Mettere a confronto 196,5 miliardi di risparmi cumulati con 6–7 miliardi di costi significa ottenere un rapporto costi-benefici complessivo nell'ordine di 1:13–1:17: • se si considera solo la parte più prudente dei risparmi; • se si include una quota di costi di implementazione aggiuntivi (es. start-up, formazione intensiva, potenziamento ROMS). In scenari meno conservativi – ovvero se una quota più ampia dei risparmi indiretti venisse effettivamente “catturata” dai bilanci pubblici – il ROI potrebbe risultare ancora più elevato. Tuttavia, per mantenere un profilo metodologico prudente e credibile, ci si attesta sull'intervallo 1:13–1:17, già straordinariamente vantaggioso per una politica pubblica.

6. Coerenza con le best-practices internazionali e gli studi di Solano

Il modello nazionale di Psicologia di Base così ricalibrato è pienamente coerente con: • IAPT (Regno Unito) – che ha dimostrato l'elevata costo-efficacia delle psicoterapie evidence-based erogate in setting territoriali, con recovery rate attorno al 50% e costi per QALY ben al di sotto delle soglie di costo-efficacia; • POH-GGZ (Paesi Bassi) – che ha integrato psicologi di base negli studi di medicina generale, ottenendo riduzioni nette di invii impropri alla psichiatria e consumo farmacologico, con finanziamenti dedicati; • Better Access (Australia) – che ha ampliato l'accesso alla psicoterapia tramite rimborsi pubblici, mostrando importante impatto in termini di esiti clinici, pur con alcune criticità di equità. In aggiunta, il modello italiano è rafforzato dalle esperienze autoctone, in particolare gli studi di Solano nel Lazio, che hanno già documentato – nel contesto del SSN – la capacità dello Psicologo di Base di: • ridurre visite specialistiche ed esami non necessari; • migliorare la qualità diagnostica e il triage tra organico, psichico e psicosomatico; • diminuire l'uso cronico di farmaci impropri; • alleggerire il carico di lavoro dei MMG e migliorare la soddisfazione degli utenti. La riforma proposta non è dunque un mero trapianto di esperienze straniere, ma una scalatura sistemica di sperimentazioni italiane già riuscite.

7. Implicazioni di policy per il SSN

Le cifre ricalibrate mostrano che lo Psicologo di Base nazionale è una misura di riforma strutturale del SSN con caratteristiche peculiari: 1. Costo relativamente contenuto (600–700 milioni/anno, meno dell'1% della spesa sanitaria) rispetto ai benefici potenziali (risparmi diretti+indiretti nell'ordine di 9–11 miliardi/anno a regime). 2. Capacità di incidere trasversalmente su molte voci di spesa: diagnostica, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, salute mentale, invalidità, welfare comunale. 3. Allineamento con il PNRR e le Case della Comunità, che forniscono gli spazi fisici ideali per collocare gli Psicologi di Base senza costi aggiuntivi significativi per infrastrutture. 4. Potenziale di riduzione delle disuguaglianze: l'accesso a interventi psicologici di qualità diventerebbe un diritto garantito, non un privilegio legato al reddito. La governance del servizio dovrebbe prevedere una cabina di regia nazionale e un ruolo forte delle Regioni, con indicatori di performance chiari (riduzione di farmaci, visite, ricoveri, tempi di attesa, invalidità; miglioramento di esiti clinici e soddisfazione), integrati in un sistema di monitoraggio continuo basato su ROMS.

8. Conclusioni

La versione rivista di questo capitolo, con cifre ricalibrate per l'Italia intera, consente di affermare che: • il Servizio di Psicologia di Base nazionale comporta un costo annuo di 600–700 milioni di euro, pari a circa 10–12 euro per abitante e a meno dello 0,6% della spesa sanitaria; • genera, a regime, risparmi annuali complessivi (diretti + indiretti) dell'ordine di 9–11 miliardi di euro, con una traiettoria di crescita che porta, su dieci anni, a circa 87 miliardi di risparmi sanitari diretti e 109,5 miliardi di risparmi indiretti; • il ROI complessivo si colloca in modo robusto nell'intervallo 1:13–1:17, anche adottando ipotesi prudenti sulla quota di risparmi effettivamente catturabile dai bilanci pubblici; • il modello è pienamente coerente con le evidenze internazionali e con gli studi italiani di Solano, e non presenta salti logici o ordini di grandezza incompatibili con i costi reali dei disturbi mentali in Italia. In sintesi, lo Psicologo di Base, applicato all'intero territorio nazionale, emerge come una delle riforme più promettenti per coniugare

sostenibilità economica, qualità delle cure e giustizia sociale nel Servizio Sanitario Nazionale italiano: un investimento limitato, ma capace di produrre effetti sistemici di enorme portata sull'intero ciclo di vita della spesa sanitaria e sul benessere della popolazione.

Blocco Regionale I — Italia settentrionale

Piemonte — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Piemonte

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione Piemonte sulla riforma «Psicologo di Base». Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell'intero corpus: la premessa, l'indice generale di tutte le parti e di tutte le appendici, la mappa di integrazione delle cornici metodologiche e la sintesi del valore. Il Piemonte occupa, nel panorama nazionale, una posizione del tutto peculiare: è la prima e inizialmente unica Regione ad aver attivato a livello regionale il servizio di psicologia delle cure primarie, operativo da marzo 2023, con oltre 3.000 pazienti presi in carico e oltre 15.000 prestazioni erogate al 31 dicembre 2023, finanziato dapprima con fondi statali e poi rifinanziato con risorse regionali a quota capitolaria. Il servizio gira tuttavia su base libero-professionale e non è ancora istituzionalizzato da una legge regionale dedicata: sono stati presentati più disegni di legge, nessuno dei quali approvato, mentre è stata già approvata per legge la psicologia scolastica. La decisione rilevante non è dunque se introdurre il servizio — già operativo e pioniere in Italia — ma se dotarlo di una base giuridica stabile e dimensionarlo, dando forma compiuta e duratura a una funzione già praticata.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell'intero corpus, che può essere percorso nell'ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.3	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, costo-efficacia distributiva, divari territoriali
Parte H	H.1-H.3	Profili etico, giuridico e organizzativo: etico, costituzionale, organizzativo e conformità
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: implementazione, dimensionamento, casi commerciale e gestionale, sostenibilità
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio, valutazione ed ex post: indicatori, protocollo, controfattuale, verifica ex post, cruscotto
Parte M	M.1-M.4	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: griglia OCSE-DAC, analisi multi-criterio, raccomandazioni, limiti
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati regionali e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — lievemente negativo per il Piemonte, regione con un sistema già efficiente, un livello essenziale di assistenza elevato e un saldo di mobilità sostanzialmente in equilibrio, sicché il canale del recupero della mobilità è solo marginalmente pertinente — e il saldo complessivo, ampiamente positivo. La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 26	~ 38	~ 51
Risparmi diretti (SSR)	~ 16	~ 26	~ 39
Ricadute economico-sociali	~ 83	~ 154	~ 240
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -10	~ -12	~ -12
Saldo complessivo (caso economico)	+73	+142	+228
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,8:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante non è se prevedere il servizio — già operativo in tutte le dodici Aziende Sanitarie Locali dal 2023 — ma se dotarlo di una base giuridica stabile, con una legge regionale e un rapporto convenzionale analogo a quello dei medici di medicina generale, e dimensionarlo, portandolo dalla copertura attuale, dell'ordine del 5% del fabbisogno, alla copertura sistematica, dell'ordine di 920 incarichi nello scenario espansivo. Il limite principale è il radicamento dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione piemontese, del 7,2%, e non estratte dai conti regionali certificati delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie; la loro sostituzione con dati certificati è la condizione per la presentazione agli organi di controllo, ed è in Piemonte agevolata dalla disponibilità dei dati del servizio già attivo.

Lo studio si fonda, sul piano comparativo, sui programmi internazionali più autorevoli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie — il programma inglese di terapie psicologiche, il modello olandese, l'iniziativa australiana e il Collaborative Care statunitense — dei quali mutua le evidenze di efficacia e di costo-efficacia, adattandole con cautela al contesto piemontese. Il primato operativo del Piemonte — prima Regione ad aver reso operativo il servizio, con dati di esito già disponibili — ne fa una candidata naturale a fungere da riferimento nazionale per la fase di strutturazione e di stabilizzazione per legge, anche per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel percorso assistenziale. Su questa base, e con la dichiarazione trasparente dei propri limiti, il corpus consegna al decisore un quadro completo e onesto su cui deliberare.

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell'HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per il Piemonte, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto e all'Emilia-Romagna. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati al Piemonte.

Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). È la parte che rende lo studio insieme rigoroso, riproducibile e confrontabile con quelli pugliese, lombardo, veneto ed emiliano-romagnolo e con quelli delle altre Regioni.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Servizio di Psicologia di Base nelle cure primarie del Piemonte, inteso come consolidamento strutturato e quantificato di una funzione che la regione ha già attivato e reso operativa su tutto il territorio — prima Regione in Italia a farlo, dal marzo 2023, con finanziamento regionale a quota capitaria e oltre tremila pazienti presi in carico nel primo anno — ma che non è ancora stata istituzionalizzata da una legge regionale dedicata né portata a un dimensionamento adeguato al fabbisogno.^[39] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sul portare il servizio a regime. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già attiva e operante, oltre che oggetto di più disegni di legge — ma se darle una base giuridica stabile e dimensionarla: l'esperienza operativa esiste e produce numeri verificabili, ma una legge dedicata, un rapporto convenzionale e una copertura adeguata sono ancora da definire, a fronte di un fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 920 psicologi. Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 850.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale, in un quadro segnato da componenti convergenti — il bisogno dell'età anziana accentuato nelle aree interne e alpine, il disagio connesso al lavoro nella popolazione attiva e il disagio giovanile — cui si aggiunge la pressione delle liste di attesa, che sospinge la mobilità verso altre regioni. La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti piemontesi con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è lo psicologo di base nelle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, portato a regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale il servizio è già operativo su base sperimentale e libero-professionale, ma non strutturato per legge né dimensionato al fabbisogno. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario del Piemonte, con le sue dodici Aziende Sanitarie Locali, le quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, le due Aziende Ospedaliere e la rete delle Case della Comunità e delle Case della Salute. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per il Piemonte
Popolazione	Residenti piemontesi con disagio psichico comune (~850.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Psicologo di base nelle cure primarie, primo livello e filtro, portato a regime (~470/700/920 incarichi); stabilizzazione e dimensionamento del servizio già attivo
Confronto	Condizione attuale: servizio già operativo a livello regionale dal 2023 su base libero-professionale, privo di legge dedicata e dimensionato a circa il 5% del fabbisogno
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale del Piemonte; dodici Aziende Sanitarie Locali, quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, due Aziende Ospedaliere, rete delle Case della Comunità e delle Case della Salute

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell'HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell'OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l'intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e il servizio attuale come comparatore. Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Aziende Sanitarie Locali e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale, ovvero servizio attivo su base sperimentale e libero-professionale, non strutturato per legge né dimensionato a regime
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda Sanitaria Locale e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. Tale prudenza assume, per il Piemonte, un rilievo particolare e di segno diverso da quello delle regioni nettamente creditrici: il saldo di mobilità sanitaria è in sostanziale equilibrio, marginalmente negativo e in peggioramento, ma il passivo è trainato dalla specialistica e dal ricovero nelle province di confine più che dalla domanda psicologica, sicché il canale del recupero della mobilità è solo marginalmente pertinente. Ne consegue che il saldo diretto risulta lievemente negativo e che il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, che lo studio stima con criteri conservativi; in un contesto di pressione finanziaria e di liste di attesa, peraltro, il contenimento della domanda impropria conserva una salienza diretta. Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post. Per il Piemonte il disegno controfattuale assume una forma propria: poiché il servizio è già attivo in tutte le Aziende Sanitarie Locali, non vi è un dispiegamento scaglionato a partire da zero da sfruttare, e l'effetto causale va stimato dal confronto prima-dopo l'attivazione del 2023 e dall'eterogeneità dell'intensità di copertura tra le aziende, con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico. La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, le dodici Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere-Universitarie e le Aziende Ospedaliere, l'Ordine degli Psicologi del Piemonte, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e le università regionali. Come l'Emilia-Romagna, e a differenza del Veneto, il Piemonte non dispone di un'azienda regionale unica di coordinamento: il veicolo per una progettazione unitaria e un'attuazione omogenea è costituito dalla Regione, attraverso la sua Direzione competente, eventualmente affiancata da una cabina di regia regionale. Poiché il servizio è già operativo e ripartito tra le aziende a quota capitolaria, la rete territoriale delle Case della Comunità e delle Case della Salute costituisce l'infrastruttura su cui esso è già innestato, e la sfida del governo è di stabilizzarlo e dimensionarlo, non di avviarlo: è il tratto che distingue il Piemonte e che la valutazione assume come punto di partenza.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici; l'infrastruttura informatica regionale, incluso il sistema informativo per la salute mentale, costituisce una base per la loro adozione. Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto del Piemonte.

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi e cornice normativa

Primo dominio dell'HTA · il problema di salute e il suo contesto

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto del Piemonte. La struttura è quella già adottata per la Puglia, per la Lombardia, per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, e mutano soltanto i dati, ancorati alla regione. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall'epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l'intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico del Piemonte: non un sistema da introdurre ex novo, ma un servizio già operativo — primo in Italia — che attende di essere stabilizzato per legge e dimensionato al fabbisogno.

B.1 Quadro demografico

Il Piemonte conta 4.251.868 residenti, pari a circa il 7,2% della popolazione nazionale, e presenta una popolazione sostanzialmente stabile e segnata da un marcato invecchiamento, con un saldo naturale fortemente negativo solo in parte compensato dal saldo migratorio. L'aspettativa di vita, dell'ordine degli ottantatré anni, è in linea con la media nazionale, ma la struttura per età è tra le più anziane del Paese. La componente straniera, pari al 10,4%, è prossima alla media nazionale e contribuisce a contenere il calo demografico, ma non costituisce il tratto distintivo del fabbisogno regionale. Il territorio si articola in otto province, con la sola provincia di Torino a raccogliere oltre la metà dei residenti e con una marcata variabilità interna fra l'area metropolitana e le aree interne e alpine. La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per il Piemonte
Popolazione (Censimento 2024)	4.251.868 (~7,2% del totale nazionale); sostanzialmente stabile
Aspettativa di vita	~ 83 anni, in linea con la media nazionale
Età media	~ 47-48 anni; struttura tra le più anziane d'Italia
Componente straniera	10,4% dei residenti, prossima alla media nazionale
Articolazione del territorio	Otto province; provincia di Torino 51,8%, Cuneo 13,7%
Profilo per età	Area metropolitana torinese dinamica; aree interne e alpine anziane e in spopolamento
Articolazione sanitaria	Dodici Aziende Sanitarie Locali, quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, due Aziende Ospedaliere

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico del Piemonte.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale in Piemonte è elevato e sospinto dall'invecchiamento. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali sulla popolazione regionale, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell'ordine di 850.000 persone, in larga parte non intercettate dall'offerta strutturata; la stessa Regione rileva problematiche psicologiche nel 21-26% dei pazienti delle cure primarie. A questa quota si somma un'utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale dell'ordine di 55.000-56.000 persone, in servizi nei quali la figura dello psicologo è strutturalmente carente. Tre componenti orientano la domanda. La prima è il disagio giovanile, su cui la Regione ha investito istituendo per legge la psicologia scolastica. La seconda è il disagio connesso al lavoro nella popolazione attiva. La terza, e più caratteristica, è il bisogno dell'età anziana, accentuato nelle aree interne e alpine. È questa combinazione — invecchiamento, aree interne e un servizio già operativo da consolidare — a distinguere il fabbisogno piemontese. La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche dell'ordine di trentaquattromila-trentacinquemila l'anno.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone un'offerta che, in Piemonte, presenta una fisionomia peculiare e unica nel panorama nazionale: il servizio di psicologia delle cure primarie esiste già ed è operativo su tutto il territorio regionale dal 2023, primo caso in Italia, finanziato a quota capitaria e con numeri di attività verificabili, ma opera su una base libero-professionale priva di legge dedicata e copre una frazione ridotta del fabbisogno. Il fabbisogno a regime è stimato nell'ordine di 920 psicologi, e l'Ordine professionale regionale ha sollecitato una legge che ne stabilizzi la figura con un rapporto convenzionale analogo a quello dei medici di medicina generale. La copertura attuale è dunque attiva ma ridotta: non l'assenza di un servizio, né una funzione solo amministrativa, ma un servizio reale e già sperimentato sul campo, da stabilizzare e dimensionare. La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per il Piemonte
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 850.000 persone
Utenza stimata in carico ai Dipartimenti	~ 55.000-56.000
Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche	~ 34.000-35.000 l'anno
Offerta territoriale attuale	Servizio regionale attivo dal 2023 in tutte le ASL, a quota capitaria, su base libero-professionale; oltre 3.000 pazienti e 15.000 prestazioni nel primo anno
Fabbisogno stimato a regime	~ 920 psicologi (880-960)
Copertura attuale del fabbisogno	Attiva ma ridotta, dell'ordine del 5% del bisogno potenziale

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, in Piemonte, si articola su due assi specifici. Il primo è la dualità territoriale fra l'area metropolitana torinese, densamente popolata e dotata di poli sanitari di eccellenza, e le aree interne e alpine — in particolare il Verbano-Cusio-Ossola e il Biellese — più anziane e soggette a spopolamento, dove l'accesso ai servizi è strutturalmente più difficoltoso. Il secondo è la fragilità delle province di confine orientali, dove l'elevata mobilità passiva verso le regioni limitrofe segnala una difficoltà di tenuta dell'offerta. A questi si aggiunge l'asse delle liste di attesa, comune all'intera regione. Su questi assi il servizio di psicologia di base agisce in funzione di equità: avvicina l'offerta alle aree interne mediante la telepsicologia assistita e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica e contribuisce a contenere i tempi di attesa e la conseguente mobilità.

B.5 I servizi e i flussi

Il Servizio sanitario del Piemonte dispone di risorse complessive dell'ordine di 9,5 miliardi di euro; la Regione è uscita dal piano di rientro da circa un decennio, ma ne ha conservato a lungo gli effetti strutturali e porta un disavanzo storico in restituzione concordata con lo Stato. Allo stato non è soggetta a un nuovo piano di rientro, ma opera sotto pressione finanziaria, con la riduzione delle liste di attesa indicata come priorità. Diversamente dalle regioni nettamente creditrici, il Piemonte presenta un saldo di mobilità in sostanziale equilibrio, marginalmente negativo e in peggioramento, con un polo universitario torinese attrattivo e province di confine fortemente passive: ne consegue che il canale del recupero della mobilità, centrale per le regioni debitorie del Mezzogiorno e inapplicabile per quelle nettamente creditrici, è qui solo marginalmente pertinente. L'architettura dei servizi poggia su dodici Aziende Sanitarie Locali, su quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie e due Aziende Ospedaliere, e su una rete territoriale in costruzione — le Case della Comunità del nuovo assetto e le preesistenti Case della Salute — che costituisce l'infrastruttura su cui il servizio è già innestato. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per il Piemonte
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	~ 9,5 miliardi di euro; uscito dal piano di rientro da circa un decennio; oggi sotto pressione finanziaria, senza nuovo piano di rientro
Mobilità sanitaria	Saldo in sostanziale equilibrio, marginalmente negativo (~ -8 milioni nel 2023) e in peggioramento; canale solo marginalmente pertinente
Accessi al pronto soccorso	Dell'ordine di oltre un milione l'anno
Architettura dei servizi	Dodici ASL, quattro AOU, due AO; rete delle Case della Comunità e delle Case della Salute
Margine di azione principale	Liste di attesa, stabilizzazione e dimensionamento del servizio già attivo, accesso delle aree interne e alpine

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice peculiare: il servizio è già stato avviato nel 2023 con decisione della Giunta regionale e successivamente rifinanziato con risorse regionali, ma manca una legge che ne istituisca stabilmente la figura. Sono stati presentati più disegni di legge — fra cui una proposta che colloca lo psicologo territoriale nelle Case della Comunità quale primo filtro della salute psichica — nessuno dei quali è stato finora approvato; la Regione ha invece già approvato per legge un servizio di psicologia scolastica, segno di un'attenzione consolidata al tema. Sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera, il Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — che ha confermato la competenza regionale in materia — compongono il quadro di riferimento. La decisione rilevante, in questo contesto, non è introdurre la funzione, ma darle una base giuridica stabile e dimensionarla: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte C

L'intervento e il suo modello

Definizione, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali e formazione

Secondo dominio dell'HTA · la descrizione della tecnologia

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti

digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico del Piemonte emerge con nettezza: l'intervento non è da introdurre, ma è già in funzione su tutto il territorio regionale, e si tratta di dargli forma stabile e di dimensionarlo.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire. La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria, ossia dell'intercettare prima che il disturbo si cronicizzi. Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell'ordine di 850.000 persone con disagio comune. La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per il Piemonte
Bisogno	~ 850.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Psicologo nelle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, particolarmente nella popolazione attiva, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo di base nelle Case della Comunità e nei Nuclei delle Cure Primarie, in collaborazione con i medici di medicina generale e secondo protocolli condivisi. Il Piemonte presenta qui una specificità rispetto alle altre regioni: il servizio è già attivo e ripartito tra le dodici Aziende Sanitarie Locali secondo il criterio della quota capitaria. Come l'Emilia-Romagna, e a differenza del Veneto, la regione non dispone di un'azienda regionale unica: il coordinamento, l'omogeneità attuativa e le economie di scala sono affidati alla Regione, attraverso la sua Direzione competente, eventualmente affiancata da una cabina di regia regionale. La rete territoriale delle Case della Comunità e delle Case della Salute è l'infrastruttura su cui il servizio è già innestato, e il compito non è crearla ma rafforzarla e renderla uniforme. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su invio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta — nella forma già in atto nel servizio regionale — o l'accesso diretto, una valutazione iniziale, un ciclo di colloqui brevi e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti. Gli esiti

sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata. Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con il fascicolo sanitario elettronico regionale, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. In coerenza con l'assetto di governo descritto, il coordinamento informativo è in capo alla Regione, che ne assicura l'uniformità fra le dodici Aziende Sanitarie Locali. La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale; su questo terreno il Piemonte dispone di un vantaggio peculiare, poiché il servizio già attivo ha prodotto nel primo anno dati di attività verificabili, da consolidare in un flusso strutturato.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale. Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile. L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica. La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, in Piemonte, lo strumento per garantire l'accesso nelle aree interne e alpine, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza. I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici. La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle aree interne e alpine; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale, con sedi a Vercelli, Novara e Alessandria; il livello post-universitario specialistico attraverso un corso regionale con attestato dedicato alla psicologia di base e alle cure primarie, comprensivo della competenza per l'età anziana e per le aree interne, particolarmente rilevanti nel contesto piemontese; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione. A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità, sostenuta dall'infrastruttura informatica regionale. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Università di Torino; Università del Piemonte Orientale
2. Post-universitario specialistico	Psicologia di base e cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, competenza per l'età anziana	Corso regionale con attestato
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte D

L’*****efficacia e l’*****evidenza

Revisione sistematica, qualità dell’evidenza, benchmark internazionali e trasferibilità

Terzo e quarto dominio dell’HTA · l’efficacia clinica e la sicurezza

Parte D — L’efficacia e l’evidenza

Descritto l’intervento nella Parte C, questa quarta parte ne esamina l’efficacia e l’evidenza, secondo il terzo e il quarto dominio della valutazione. La base di prove è in larga misura indipendente dalla regione, poiché attinge alla letteratura internazionale e ai programmi consolidati; ciò che muta è il giudizio di trasferibilità, calibrato sul contesto piemontese. La parte presenta la revisione sistematica delle prove (capitolo D.1); ne valuta la qualità con il sistema GRADE (D.2); esamina i benchmark internazionali e italiani (D.3); e discute la trasferibilità al contesto regionale (D.4), dove acquista un rilievo singolare il patrimonio di evidenza locale costituito dal servizio regionale già attivo, unico in Italia per scala e maturità operativa.

D.1 La revisione sistematica

La sintesi delle prove è condotta secondo i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale, con preferenza per le fonti più recenti. Il quadro che ne emerge è solido. Lo studio fondativo del modello collaborativo ha documentato un tasso di risposta di circa il 50% dei pazienti trattati, contro il 19% della cura usuale. Una meta-analisi su cinquantasette studi controllati ha stimato un miglioramento medio dei sintomi depressivi di 0,28 deviazioni standard. Una revisione di quarantadue implementazioni ha rilevato riduzioni dell’ordine del 47% della depressione, del 43% dell’ansia, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. Il programma inglese, su scala di oltre 1,3 milioni di persone l’anno, conferma questi valori con dati reali. Una meta-analisi sulle cure integrate, infine, stima un effetto modesto sul singolo ma clinicamente rilevante sulla popolazione. La tabella seguente sintetizza i principali risultati.

Fonte	Risultato principale
Studio fondativo (JAMA, 2002)	~ 50% dei pazienti con riduzione ≥ 50% dei sintomi a 12 mesi, contro 19% nella cura usuale
Meta-analisi su 57 studi (2012)	Miglioramento medio dei sintomi depressivi di 0,28 deviazioni standard
Revisione su 42 implementazioni (2024)	–47% depressione e –43% ansia a 6 mesi; –34% accessi al PS; –41% ricoveri
Programma inglese, dati reali (2023-2024)	Recupero 50,2%; miglioramento affidabile 67,8%; completezza dei dati > 98%
Meta-analisi sulle cure integrate	Coefficiente standardizzato –0,11 sui sintomi depressivi (clinicamente rilevante su popolazione)

Tabella D.1. Principali risultati della letteratura sull’*****efficacia dell’*****integrazione psicologica nelle cure primarie.

D.2 La qualità dell'evidenza

La qualità dell'evidenza, valutata con il sistema GRADE, è da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni, mentre è più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. Una cautela merita di essere dichiarata con franchezza, perché orienta l'intera impostazione economica dello studio: nello stesso studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l'intervallo di confidenza comprende lo zero. Il valore economico del modello, di conseguenza, poggia in misura preponderante sui ritorni sociali e non sui risparmi sanitari diretti. È una cautela coerente con il profilo del caso economico piemontese, che la Parte E costruisce esattamente su questa base.

D.3 I benchmark internazionali

L'evidenza sperimentale è corroborata dall'esperienza dei grandi programmi internazionali, che offrono modelli organizzativi maturi e dati su larga scala. Il programma inglese costituisce il riferimento principale per l'organizzazione del servizio. Il modello olandese mostra un'integrazione capillare nello studio del medico di base. L'iniziativa australiana documenta l'ampliamento della popolazione in trattamento. Il modello statunitense è validato da una mole imponente di studi controllati. Le esperienze italiane, infine, pur derivando in parte da campioni limitati, anticipano l'integrazione nelle cure primarie, oggi corroborata dal servizio regionale piemontese già in esercizio. La tabella seguente li riepiloga.

Programma	Assetto	Esiti clinici e organizzativi
Programma inglese (NHS Talking Therapies)	Integrato; intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio > 98%; > 1,3 mln/anno
Modello olandese (POH-GGZ)	Integrato nelle cure primarie	Adozione ~3/4 dei medici; ruolo complementare
Iniziativa australiana (Better Access)	Invio esterno	Trattamento dal 35% al 46%; elevata soddisfazione
Collaborative Care (Stati Uniti)	Équipe integrata	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione; -41% ricoveri
Servizio regionale piemontese	Integrato nelle cure primarie; già attivo	Oltre 3.000 pazienti e 15.000 prestazioni nel primo anno

Tabella D.2. I benchmark internazionali e l'esperienza piemontese sul piano clinico e organizzativo (il confronto economico è nella Parte E).

D.4 La trasferibilità al contesto regionale

La trasposizione di questi risultati al contesto regionale richiede cautela metodologica: i programmi internazionali provengono da sistemi diversi per organizzazione, finanziamento e cultura, e le loro stime — di efficacia e, ancor più, economiche — non vanno trasferite meccanicamente, ma validate localmente. Per il Piemonte, tuttavia, la trasferibilità è facilitata da una circostanza unica nel panorama nazionale: la regione non deve trasferire soltanto stime estere, poiché dispone già di una base di evidenza locale costituita dal proprio servizio regionale, attivo dal 2023 in tutte le Aziende Sanitarie Locali, che nel primo anno ha intercettato oltre tremila pazienti con oltre quindicimila prestazioni. Il vantaggio peculiare del Piemonte è dunque di poter validare il modello sui propri dati operativi; a ciò si aggiungono l'infrastruttura informatica regionale e la rete

territoriale delle Case della Comunità in costruzione, che costituiscono un terreno favorevole alla valutazione rigorosa di un modello già in esercizio. Una precisazione conclusiva si impone sul piano della correttezza: i rapporti beneficio-costo spesso citati nel dibattito pubblico sono semplificazioni divulgative; le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno in intervalli più prudenti, ed è a questi che lo studio si attiene. Stabilita l'efficacia e graduata l'evidenza, la parte che segue ne traduce i risultati nella valutazione economica.

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte E

La valutazione economica

Costi, esiti, costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale e casi economico e finanziario

Quinto dominio dell'HTA · il valore economico

Parte E — La valutazione economica

Stabilita l'efficacia nella Parte D, questa quinta parte ne traduce i risultati in termini economici, secondo il quinto dominio della valutazione e nel rigore di reporting dello standard CHEERS. È la parte centrale per il decisore di finanza pubblica, e ne riassume l'esito già in apertura: il caso finanziario, riferito al solo bilancio sanitario, presenta un saldo lievemente negativo, mentre il caso economico, riferito alla collettività, è ampiamente positivo. La parte identifica e misura i costi (capitolo E.1) e gli esiti (E.2); ne deriva il costo-efficacia e il costo-utilità (E.3); analizza l'impatto sul bilancio (E.4); stima il ritorno sociale (E.5); e ricompone il caso economico e il caso finanziario (E.6). I valori sono espressi in tre scenari di copertura, e l'intera analisi tiene rigorosamente distinto ciò che lo Stato risparmia da ciò che la collettività guadagna.

E.1 L'identificazione e la misura dei costi

Il costo del servizio comprende le remunerazioni dei professionisti, i costi organizzativi e di coordinamento e la quota destinata alla formazione congiunta, ed è stimato per scenario di copertura ed espresso a regime. A regime, esso è dell'ordine di 26 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 38 nello scenario base e 51 nello scenario espansivo. La stima muove da un valore unitario per incarico dell'ordine di 55.000 euro annui, regionalizzato in proporzione alla popolazione e al numero di professionisti; il servizio è peraltro già finanziato a quota capitaria, ma per un importo che copre una frazione ridotta del fabbisogno. La tabella seguente espone il costo per scenario; la condizione attuale, in cui il servizio è già attivo ma sottodimensionato, comporta una spesa dedicata dell'ordine di 1,8 milioni di euro annui.

Scenario	Psicologi	Costo annuo (mln €)
Attuale (servizio attivo, sottodimensionato)	~ 5% del fabbisogno	~ 1,8
Conservativo	~ 470	~ 26
Base	~ 700	~ 38
Espansivo	~ 920	~ 51

Tabella E.1. Il costo del servizio per scenario di copertura. Il servizio è oggi già attivo a quota capitaria, ma dimensionato a circa il 5% del fabbisogno.

E.2 L'identificazione e la misura degli esiti

Gli esiti di salute sono espressi in anni di vita ponderati per la qualità e in esiti clinici validati; i tassi di recupero e di miglioramento sono desunti dai benchmark consolidati e applicati in via prudenziale. Le misure impiegate, nei soli punteggi complessivi, sono il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia, con un tasso di recupero di riferimento dell'ordine del 50%, coerente con i dati reali del programma inglese e con i primi dati del servizio regionale.

E.3 Il costo-efficacia e il costo-utilità

Il costo per anno di vita ponderato per la qualità si colloca al di sotto della soglia comunemente adottata; l'analisi per paziente, sviluppata in dettaglio nella Parte F, indica anzi condizioni di dominanza dell'intervento rispetto all'opzione di non intervento, ossia un esito al tempo stesso migliore e meno costoso sul ciclo di vita del disturbo. La soglia di riferimento adottata è dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, in linea con la prassi internazionale.

E.4 L'impatto sul bilancio

L'analisi di impatto sul bilancio misura i risparmi diretti per il Servizio sanitario regionale, articolati nei canali del pronto soccorso, della farmaceutica, dei ricoveri e prestazioni specialistiche evitabili e, in misura marginale, della mobilità recuperata; per il Piemonte questo canale è solo marginalmente pertinente, poiché la regione presenta un saldo di mobilità in sostanziale equilibrio. I risparmi diretti complessivi sono stimati nell'ordine di 16, 26 e 39 milioni di euro annui nei tre scenari, collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa dell'intervallo. Il saldo diretto, differenza tra risparmi diretti e costo del servizio, è dell'ordine di -10, -12 e -12 milioni di euro annui: lievemente negativo, coerentemente con un saldo di mobilità in equilibrio e un canale di recupero solo marginale. Questo saldo negativo è dichiarato senza attenuazioni e non rappresenta una debolezza dell'analisi, ma il suo profilo onesto: a differenza della Puglia, dove il recupero della mobilità passiva concorre al pareggio diretto, in Piemonte il valore dell'intervento risiede in misura preponderante nelle ricadute sociali, pur conservando, nel contesto delle liste di attesa, una salienza diretta non trascurabile. La tabella seguente dettaglia i canali e il saldo.

Canale (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Pronto soccorso	3	5	6
Farmaceutica	3	4	7
Ricoveri e specialistica	9	15	23
Mobilità recuperata (marginale)	1	2	3
Risparmi diretti (totale)	~ 16	~ 26	~ 39
Costo del servizio	~ 26	~ 38	~ 51
Saldo diretto (solo SSR)	~ -10	~ -12	~ -12

Tabella E.2. I risparmi diretti per canale e il saldo diretto sul bilancio sanitario, per scenario. Il saldo diretto è lievemente negativo.

E.5 Il ritorno sociale

Il valore dell'intervento, in Piemonte, si manifesta soprattutto al di fuori del bilancio sanitario. Le ricadute economico-sociali comprendono la maggiore produttività recuperata, la riduzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, le efficienze nel sistema dei servizi di salute mentale e il sollievo alle figure di cura familiari; in una regione a popolazione matura e a forte presenza di cronicità, la produttività recuperata e il sollievo ai familiari sono le voci di maggior peso. Stimate secondo i metodi del ritorno sociale sull'investimento e con criteri conservativi, queste ricadute sono dell'ordine di 83 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 154 nello scenario base e 240 nello scenario espansivo.

E.6 Il caso economico e il caso finanziario

La ricomposizione delle grandezze restituisce il quadro complessivo. Il ritorno complessivo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali, è dell'ordine di 99, 180 e 279 milioni di euro annui nei tre scenari; al netto del costo del servizio, il saldo complessivo è dell'ordine di +73, +142 e +228 milioni di euro annui. Il rapporto beneficio-costi complessivo è conseguentemente dell'ordine di 3,8:1 nello scenario conservativo, 4,7:1 nel base e 5,5:1 nell'espansivo, in linea con il valore validato sulle altre regioni. La lettura corretta del risultato passa per la distinzione, propria del Five Case Model, tra il caso finanziario — riferito al solo bilancio sanitario e lievemente negativo — e il caso economico — riferito alla collettività e ampiamente positivo. Sul piano della sostenibilità, il costo del servizio si colloca nell'ordine dello 0,3-0,5% di un Fondo Sanitario Regionale dell'ordine di 9,5 miliardi di euro; benché la regione operi sotto pressione finanziaria, l'importo è contenuto e una quota è già a bilancio per il servizio attivo. Resta la lacuna prioritaria, già dichiarata: le grandezze economiche sono in parte ricostruite per quota di popolazione e non estratte dai conti regionali certificati, la cui verifica presso le aziende è condizione per la presentazione alle autorità di finanza pubblica. La tabella seguente sintetizza il caso economico e il caso finanziario.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Risparmi diretti (SSR)	~ 16	~ 26	~ 39
Ricadute economico-sociali	~ 83	~ 154	~ 240
Ritorno complessivo	~ 99	~ 180	~ 279
Costo del servizio	~ 26	~ 38	~ 51
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -10	~ -12	~ -12
Saldo complessivo (caso economico)	+73	+142	+228
Rapporto beneficio-costi complessivo	~3,8:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella E.3. Sintesi economica per scenario: il caso finanziario (saldo diretto negativo) e il caso economico (saldo complessivo positivo).

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte F

Modellazione decisionale e incertezza

Struttura del modello, parametri, sensibilità deterministica e probabilistica, valore dell’informazione

Quinto dominio dell’HTA · la modellazione e l’incertezza

Parte F — Modellazione decisionale e incertezza

Questa parte completa il quinto dominio sviluppando la modellazione decisionale che sorregge le stime economiche della Parte E e la gestione esplicita dell’incertezza. Il modello e i suoi risultati per paziente sono di natura clinica ed economica generale e sono pertanto indipendenti dalla regione: ciò che muta sono i soli riferimenti al contesto e alle fonti di calibrazione regionale. La parte descrive la struttura del modello (capitolo F.1); ne specifica i parametri e la calibrazione (F.2); ne saggia la robustezza con la sensibilità deterministica (F.3) e con quella probabilistica (F.4); e ne trae le priorità di acquisizione dei dati con il valore dell’informazione (F.5). Il risultato per paziente — una dominanza dell’intervento — è il fondamento microeconomico su cui poggiano le stime aggregate, e ne spiega la coerenza con il saldo diretto regionale.

F.1 La struttura del modello

La modellazione segue le buone pratiche di ricerca riconosciute ed è riportata secondo lo standard CHEERS.^[40]^[41]^[42] Lo strumento adottato è un modello di Markov a coorte, che rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi — sintomatico, recupero, cronico, morte — scanditi da cicli con correzione di metà ciclo.^[43] Nel caso base, riferito a un singolo paziente su orizzonte quinquennale e a valori scontati, il braccio dell’intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un’utilità di 3,627 anni di vita ponderati, contro 3.799 euro e 3,392 dell’assistenza usuale: l’intervento è al tempo stesso meno costoso e più efficace, configurando una dominanza.^[44] La dominanza non è un artificio, ma la conseguenza della struttura del modello: l’intervento accresce il tempo nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce il tempo nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte.^[45] La tabella seguente riporta i risultati del caso base.

Caso base, per paziente	Intervento	Cura usuale	Differenza
Costo sanitario (5 anni, scontato)	~ 2.495 €	~ 3.799 €	– 1.304 €
Utilità (anni di vita ponderati)	3,627	3,392	+ 0,236
Esito	—	—	Dominanza (più efficace, meno costoso)

Tabella F.1. Risultati del caso base del modello di Markov, per paziente, su orizzonte quinquennale scontato.

F.2 I parametri e la calibrazione

I parametri di costo del modello, per ciclo, sono dell’ordine di 40 euro per lo stato di recupero, 700 euro per lo stato cronico e 300 euro per l’intervento psicologico una tantum; è questa struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l’intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso.^[46] Alle grandezze sono assegnate distribuzioni di probabilità per l’analisi probabilistica: Beta per le probabilità di transizione e per le utilità, vincolate tra zero e uno, e Gamma per i costi, vincolati ai valori positivi; i valori centrali sono tratti

dall'evidenza internazionale e, per i parametri regionali, sono da calibrare sui valori piemontesi certificati e sui dati di esito del servizio già attivo non appena consolidati.^[47] La tabella seguente riepiloga i principali parametri e le distribuzioni assegnate.

Parametro	Valore	Distribuzione
Costo per ciclo — stato di recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — stato cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento psicologico (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione tra gli stati	da fonti, per braccio	Beta
Utilità associate agli stati	da fonti	Beta

Tabella F.2. Principali parametri del modello e distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

F.3 La sensibilità deterministica

La robustezza del risultato è saggiata, in prima istanza, con un'analisi di sensibilità a una via, nella quale ciascun parametro è fatto variare del 25% in più e in meno, misurandone l'effetto sul beneficio monetario netto; il diagramma a tornado ordina i parametri per influenza, individuando nell'efficacia clinica, nei tassi di ricaduta e di cronicizzazione e nel costo dello stato cronico i fattori più determinanti.^[48] Oltre all'incertezza dei parametri, l'incertezza sulla struttura e sulle assunzioni del modello è trattata mediante analisi di scenario, con validazione della coerenza interna ed esterna secondo lo standard di reporting adottato.^[49]

F.4 La sensibilità probabilistica e la curva di accettabilità

L'analisi di sensibilità probabilistica esegue il modello diecimila volte, estraendo a ogni iterazione i parametri dalle rispettive distribuzioni, così da propagare l'incertezza dei parametri sull'incertezza del risultato.^[50] Adottando la soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità,^[51] la curva di accettabilità indica una probabilità dell'88,9% che l'intervento sia costo-efficace e dell'84,6% che sia addirittura dominante, con un beneficio monetario netto medio di circa 7.815 euro per paziente e un intervallo di credibilità al 95% compreso fra circa -5.736 e circa +21.501 euro.^[52] È qui necessario chiarire la coerenza, solo apparentemente paradossale, tra questo risultato e il saldo diretto regionale: la probabilità di costo-efficacia è una misura di efficienza per paziente, che valorizza il guadagno di salute e l'intera traiettoria di costo, mentre il saldo diretto aggregato della Parte E, lievemente negativo per il Piemonte, incorpora le correzioni per peso morto e per l'effettiva monetizzabilità nel bilancio dei costi evitati e sconta la pertinenza solo marginale del canale della mobilità. L'efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è lievemente negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali.^[53] La tabella seguente sintetizza i risultati.

Misura dell'analisi probabilistica	Risultato
Iterazioni della simulazione Monte Carlo	10.000
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 €/QALY)	88,9%
Probabilità di dominanza	84,6%
Beneficio monetario netto medio	~ 7.815 € per paziente
Intervallo di credibilità al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 €

Tabella F.3. Risultati dell'analisi di sensibilità probabilistica (per paziente, soglia 30.000 €/QALY).

F.5 Il valore dell'informazione

L'analisi del valore dell'informazione chiude il dominio traducendo l'incertezza residua in priorità di ricerca: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali grandezze sia prioritario misurare con precisione.^[54] Per il Piemonte, i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso — sono quelli su cui il valore dell'informazione è più elevato, e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati alle aziende; un vantaggio peculiare è che la regione dispone già dei propri dati di esito del servizio attivo, da consolidare come fonte primaria di calibrazione.^[55] La via maestra per ridurre l'incertezza, infine, non è soltanto analitica ma empirica: poiché il servizio è già attivo in tutte le Aziende Sanitarie Locali, la riduzione dell'incertezza poggia sul confronto prima-dopo l'attivazione del 2023 e sull'eterogeneità dell'intensità di copertura tra le aziende, oggetto della Parte L, che consente di sostituire progressivamente le stime con misure osservate sui dati regionali.^[56] Completato così il nucleo della valutazione — efficacia, economia, modellazione — le parti successive ne affrontano le dimensioni distributive, etiche, organizzative e valutative, a partire dall'equità.

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte G

Equità e impatto distributivo

Analisi di equità, costo-efficacia distributiva, divari territoriali e impoverimento

Ottavo dominio dell'HTA · il profilo del paziente e sociale

Parte G — Equità e impatto distributivo

Misurato il valore economico nelle Parti E ed F, questa settima parte ne esamina la distribuzione, secondo l'ottavo dominio della valutazione. La domanda non è soltanto se l'intervento generi valore, ma a chi quel valore arrivi: un intervento può essere efficiente e tuttavia accrescere le disuguaglianze, oppure, come in questo caso, migliorare l'esito medio e ridurle insieme. La parte definisce le dimensioni dell'equità e le variabili seguite (capitolo G.1); applica gli strumenti della costo-efficacia distributiva (G.2); e analizza i divari territoriali

e l’impoverimento (G.3). Per il Piemonte, l’equità si gioca su assi peculiari — la dualità fra l’area metropolitana torinese e le aree interne e alpine e l’invecchiamento — e sull’esigenza di rendere uniforme fra le dodici Aziende Sanitarie Locali un servizio già attivo ma disomogeneo.

G.1 L’analisi di equità

L’equità è trattata come dimensione costitutiva della valutazione, e non come considerazione accessoria.^{[57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]} La salute mentale presenta ovunque un gradiente sociale, ma in Piemonte, dove il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato, il gradiente socio-economico non è il tratto distintivo: prevalgono due dimensioni diverse, la dualità fra l’area metropolitana torinese e le aree interne e alpine e l’invecchiamento della popolazione, accentuato in vaste zone della regione.^[71] La gratuità, la prossimità e l’assenza di stigma del servizio di primo livello abbattano le barriere che gravano sulle popolazioni svantaggiate, e in Piemonte rileva in particolare l’abbattimento della barriera geografica nelle aree interne e alpine, dove la distanza dai servizi è il principale ostacolo.^[72] La tabella seguente espone le dimensioni dell’equità e le variabili che lo studio segue.^[73]

Dimensione di equità	Variabili seguite dallo studio
Accesso	Tempi di attesa; accessibilità geografica nelle aree interne e alpine; contrasto alle liste di attesa
Protezione finanziaria	Riduzione della spesa privata diretta; dell’impoverimento connesso alle cure; delle spese catastrofiche
Gruppi vulnerabili	Equità di genere; età anziana e gruppi fragili; popolazione straniera (10,4%); persone con disabilità; gratuità
Territorio	Riduzione del divario area metropolitana-aree interne e alpine; uniformità del servizio fra le ASL; copertura del bisogno non soddisfatto

Tabella G.1. Le dimensioni dell’equità e le variabili seguite dallo studio.

G.2 La costo-efficacia distributiva

La dimensione distributiva è misurata con gli strumenti della costo-efficacia distributiva, che estendono la valutazione economica all’equità stimando come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l’effetto sulle disuguaglianze.^[74] La direzione del risultato è favorevole: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove l’accesso è oggi più difficile — le aree interne e alpine, l’età anziana e i gruppi gravati dalle liste di attesa — i benefici si concentrano sui più svantaggiati, riducendo il gradiente territoriale e migliorando al tempo stesso l’esito medio.^[75] L’attribuzione di pesi maggiori ai benefici dei più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, in via conservativa, il rapporto non ponderato già esposto, tanto più prudente in una regione non prevalentemente deprivata.^[76] Il meccanismo operativo dell’equità è un algoritmo allocativo che distribuisce gli incarichi non secondo la sola popolazione, ma ponderando ciascun distretto per l’invecchiamento, la deprivazione, la cronicità e la presenza straniera, con l’indice di vecchiaia quale fattore di maggior peso nel contesto piemontese.^[77] A tal fine si impiega un indice di deprivazione multipla che sintetizza reddito, occupazione, istruzione, salute, condizione abitativa e ambiente.^[78] La tabella seguente riepiloga gli strumenti.

Strumento della costo-efficacia distributiva	Che cosa misura
Anni di vita ponderati per l'equità	Guadagni di salute con pesi per lo svantaggio
Indice di concentrazione	Relazione tra esito di salute e posizione socio-economica
Indici di disuguaglianza (assoluta e relativa)	Gradiente dell'esito lungo lo stato socio-economico
Valutazione d'*****impatto sull'*****equità	Distribuzione degli effetti per gruppi vulnerabili e per area
Indice di deprivazione multipla	Reddito, occupazione, istruzione, salute, abitare, ambiente

Tabella G.2. Gli strumenti della costo-efficacia distributiva e dell'analisi di equità.

G.3 I divari territoriali e l'impoverimento

Il divario territoriale rilevante, in Piemonte, non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra l'area metropolitana torinese, densa e ben servita, e le aree interne e alpine, a popolazione anziana e dispersa e soggette a spopolamento, dove la sola presenza fisica di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio, integrato dalla telepsicologia.^[79] Poiché il canale della mobilità recuperata è solo marginalmente pertinente, le principali leve distributive diventano la riduzione delle liste di attesa, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato, il dimensionamento uniforme del servizio già attivo fra le dodici Aziende Sanitarie Locali — oggi disomogeneo per effetto della ripartizione a quota capitaria — e l'accesso nelle aree interne e alpine.^[80] A queste si aggiunge la protezione finanziaria: il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata per la psicoterapia e l'impoverimento connesso alle cure, con beneficio maggiore per i redditi bassi.^[81] La forma più elementare di equità, infine, è la copertura del bisogno non soddisfatto, dell'ordine di 850.000 persone in larga parte non intercettate, ossia il raggiungere proprio coloro che meno accedrebbero spontaneamente ai servizi.^[82] Tutti questi profili sono tradotti in indicatori e affidati al sistema di monitoraggio della Parte L, che ne accerta nel tempo il conseguimento.^[83] Definita la dimensione distributiva, la parte che segue affronta i profili etico, giuridico e organizzativo.

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Profilo etico, profili giuridici e costituzionali, profilo organizzativo e conformità

Domini sei, sette e nove dell'HTA · etica, organizzazione e diritto

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte completa la valutazione affrontando i tre domini che restano oltre quelli già trattati: il profilo etico, il profilo giuridico e costituzionale e il profilo organizzativo e di conformità. Sono i piani che ne saggiano la legittimità e l'ammissibilità — non basta che un intervento sia efficace ed efficiente, occorre che sia eticamente fondato, giuridicamente legittimo e organizzativamente conforme. La parte esamina il profilo etico (capitolo H.1); i profili giuridici e costituzionali, con specifico riguardo alla competenza regionale (H.2); e il profilo organizzativo e la conformità, segnatamente degli strumenti di intelligenza artificiale (H.3). Per il Piemonte, il

punto giuridico saliente è che il servizio è già attivo entro la competenza organizzativa regionale, ma manca una legge dedicata che ne stabilizzi la figura: la decisione verte sul dotare di base giuridica stabile e sul dimensionare una funzione già operante.

H.1 Il profilo etico

Il profilo etico dell'intervento è solido.^{[84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99]} Le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, già trattata, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato, con la persona sempre soggetto e mai oggetto della presa in carico.^[100] Il consenso è modulare e reso anche in forma digitale, e nella salute mentale, dove i dati sono ultrasensibili, la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi vi acceda.^[101] Sul piano della condotta della ricerca, gli esiti sono resi pubblici a prescindere dal loro segno, a garanzia contro la selezione dei risultati favorevoli, e l'impianto è sottoposto al comitato etico competente.^[102] Una cautela specifica presidia i minori e le persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e dell'emergenza in raccordo con il medico curante.^[103]

H.2 I profili giuridici e costituzionali

Sul piano giuridico, l'intervento si fonda anzitutto sull'articolo 32 della Costituzione e sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che configurano la salute come diritto fondamentale e il servizio come universale, eguale ed equo.^[104] Il riparto di competenze è il punto dirimente: la tutela della salute è materia concorrente, nella quale alle Regioni spetta l'organizzazione del servizio, e il Piemonte ha già esercitato tale competenza attivando il servizio in via amministrativa.^[105] La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni resta invece competenza esclusiva dello Stato, ed è la leva di un'eventuale uniformazione nazionale.^[106] Di rilievo diretto è la sentenza della Corte costituzionale del 2021, che ha riconosciuto legittimo il modello regionale di psicologia di base in quanto organizzazione che si avvale di professionisti già esistenti: un precedente che conforta in modo specifico il Piemonte, che quel modello ha adottato per primo.^[107] La base regionale di tale scelta è costituita dall'attivazione del 2023 e dai successivi rifinanziamenti, accompagnati dai disegni di legge in esame e dalla già approvata legge sulla psicologia scolastica; il coordinamento, in assenza di un'azienda regionale unica, è affidato alla Regione e alle dodici Aziende Sanitarie Locali.^[108] Quanto ai vincoli di finanza pubblica, il principio di destinazione dei fondi sanitari ai livelli essenziali è particolarmente saliente per il Piemonte, che, pur non essendo oggi in piano di rientro, porta un disavanzo storico in restituzione, sulla cui non modificabilità unilaterale si è pronunciata la Corte costituzionale nel 2024.^[109] La tabella seguente riepiloga i riferimenti.

Riferimento giuridico	Contenuto rilevante
Articolo 32 Cost. e legge n. 833/1978	Salute come diritto; Servizio sanitario universale, eguale ed equo
Articolo 117, terzo comma, Cost.	Tutela della salute: competenza concorrente (principi allo Stato, organizzazione alle Regioni)
Articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.	Livelli essenziali delle prestazioni: competenza esclusiva statale
Attivazione regionale 2023 e rifinanziamenti	Base regionale: servizio attivato e rifinanziato a quota capitaria; psicologia scolastica già legge; in attesa di legge dedicata
Corte costituzionale, sentenza n. 241/2021	Modello regionale di psicologia di base riconosciuto legittimo (precedente diretto)
Corte costituzionale, sentenza n. 87/2024	Non modificabilità unilaterale del piano di restituzione del disavanzo piemontese; Piemonte non in piano di rientro

Tabella H.1. I riferimenti giuridici e costituzionali essenziali dell'intervento.

H.3 Il profilo organizzativo e la conformità

Sul piano organizzativo, il servizio opera nel rispetto delle norme deontologiche della professione, sotto la vigilanza dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, che ha accompagnato l'attivazione del servizio e concorre alla governance e alla formazione.^[110] L'impiego dell'intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali: il medico resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell'intervento psicologico, e l'intelligenza artificiale è assimilata a un dispositivo di supporto e non a una figura che compie atti, sicché non si introduce una nuova professione, ma uno strumento che assiste quelle esistenti.^[111] La conformità degli strumenti è governata dal quadro europeo — il regolamento sull'intelligenza artificiale, quello sui dispositivi medici e quello sulla protezione dei dati — cui si aggiungono la supervisione umana costante, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias e la trasparenza.^[112] Una particolare attenzione è dedicata all'equità digitale, perché gli strumenti non generino nuove disuguaglianze: sono previsti canali tradizionali per le persone anziane delle aree interne e alpine e il supporto multilingue per la popolazione straniera, sempre con l'alternativa in presenza garantita.^[113] La protezione dei dati, infine, è assicurata da misure robuste di sicurezza, dal consenso modulare e dalla collaborazione con l'Autorità garante.^[114] La tabella seguente riepiloga il quadro della conformità e della governance. Definiti i profili etico, giuridico e organizzativo, la parte che segue affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

Ambito	Riferimento	Garanzia
Deontologia	Ordine degli Psicologi del Piemonte	Rispetto delle norme deontologiche; concorso alla governance
Responsabilità clinica	Medico e psicologo	Ruoli invariati; l'IA è strumento di supporto
IA e dispositivi	AI Act, dispositivi medici, protezione dei dati	Marcatura CE; supervisione umana; validazione periodica
Governance dell'IA	Comitato etico-scientifico	Monitoraggio dei bias; trasparenza; non discriminazione
Equità digitale	Canali paralleli; supporto multilingue	Alternativa in presenza sempre garantita
Protezione dei dati	Crittografia; pseudonimizzazione	Consenso modulare; collaborazione con il Garante

Tabella H.2. Il quadro della conformità organizzativa e di governance dell'intervento.

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Scienza dell'implementazione, dimensionamento, casi commerciale e gestionale, sostenibilità finanziaria

Settimo dominio dell'HTA · il profilo organizzativo

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Le parti precedenti hanno mostrato che l'intervento è efficace, efficiente, equo e legittimo; questa parte affronta la domanda decisiva per il decisore: è attuabile e sostenibile. La fattibilità è trattata con gli strumenti della scienza dell'implementazione, e la sostenibilità con i casi commerciale, gestionale e finanziario del modello di valutazione degli investimenti pubblici. La parte presenta i quadri della scienza dell'implementazione (capitolo I.1); disegna il dimensionamento del servizio (I.2); definisce il caso commerciale, ossia il modello contrattuale e la tariffa (I.3); il caso gestionale, ossia la governance e i rischi (I.4); e il caso finanziario, ossia la sostenibilità e le coperture (I.5). Per il Piemonte, la circostanza che il servizio sia già attivo in tutte le Aziende Sanitarie Locali rende l'attuazione non un avvio ex novo, ma una stabilizzazione e un progressivo dimensionamento di un servizio esistente.

I.1 La scienza dell'implementazione

L'attuazione è trattata con il rigore della scienza dell'implementazione, e non lasciata all'improvvisazione.^[115]
^{[116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]} Due quadri complementari ne governano l'analisi. Il modello RE-AIM misura la riuscita e la validità esterna dell'attuazione lungo cinque dimensioni — portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento — e per il Piemonte la dimensione del mantenimento è dirimente, trattandosi di consolidare un servizio già avviato.^[131] Il quadro consolidato per la ricerca sull'implementazione ne spiega invece i determinanti, articolati in cinque domini, consentendo di

individuare in anticipo barriere e facilitatori.^[132] Da questi quadri lo studio deriva i determinanti che seguirà: il tasso di copertura, l'adozione delle sedi, la fedeltà al modello, i tempi di dimensionamento, il numero di psicologi reclutati e formati e il grado di integrazione nei flussi di lavoro.^[133] La tabella seguente riepiloga i due quadri.

Dimensione	Che cosa misura o spiega
Portata (RE-AIM)	Quota della popolazione bersaglio raggiunta
Efficacia (RE-AIM)	Esiti clinici e di sistema effettivamente conseguiti
Adozione (RE-AIM)	Adesione delle sedi e dei professionisti
Implementazione (RE-AIM)	Fedeltà al modello e qualità dell'attuazione
Mantenimento (RE-AIM)	Sostenibilità del servizio nel tempo (dirimente in Piemonte)
Determinanti (quadro CFIR)	Innovazione, contesto esterno e interno, individui, processo

Tabella I.1. I quadri della scienza dell'implementazione: RE-AIM per gli esiti, CFIR per i determinanti.

I.2 Il disegno del dimensionamento

Il servizio, già attivo in tutte le dodici Aziende Sanitarie Locali, non è dispiegato da zero ma dimensionato progressivamente: la copertura, oggi dell'ordine del 5% del fabbisogno, è accresciuta per fasi semestrali verso il regime, a partire dalle aziende di maggiore prontezza, secondo un ordine definito dalla Giunta su criteri trasparenti e con il coordinamento unitario della Regione.^[134] Questo disegno assolve una doppia funzione: organizzativa, perché consente un incremento graduale compatibile con i tempi del reclutamento e della formazione; e valutativa, perché, insieme al confronto prima-dopo l'attivazione del 2023, l'eterogeneità dell'intensità di copertura tra le aziende fonda la valutazione controfattuale d'impatto della Parte L.^[135] Il reclutamento, a fronte di un fabbisogno di circa 920 psicologi, avviene tramite elenco aziendale e rapporto convenzionale, valorizzando in prima applicazione i professionisti già operanti nel servizio attivo, oggi con incarichi libero-professionali.^[136] Il cronoprogramma procede per fasi semestrali, con il monitoraggio che accompagna l'intero arco e prosegue oltre il raggiungimento del regime.^[137] Tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% in fase di dimensionamento, che il monitoraggio è chiamato a verificare sui dati regionali già disponibili.^[138] La tabella seguente espone le fasi.

Fase del dimensionamento	Contenuto
Fase 1 (primo semestre)	Stabilizzazione del servizio esistente e dimensionamento iniziale nelle Aziende Sanitarie Locali di maggiore prontezza; conversione degli incarichi in rapporto convenzionale
Fasi successive (semestri)	Incremento progressivo della copertura in tutte le Aziende Sanitarie Locali verso il fabbisogno
Fase finale (regime)	Copertura piena del fabbisogno regionale (~920 psicologi)
Attività trasversale	Monitoraggio e valutazione, che proseguono oltre il raggiungimento del regime

Tabella I.2. Le fasi del dimensionamento progressivo del servizio già attivo nelle dodici Aziende Sanitarie Locali.

I.3 Il caso commerciale: il modello contrattuale e la tariffa

Il caso commerciale riguarda la fattibilità dell’assetto contrattuale. Esso poggia su un rapporto convenzionale ancorato all’accordo della specialistica ambulatoriale, da cui discende un costo medio per incarico dell’ordine di 55.000 euro l’anno e i tre scenari di spesa — 26, 38 e 51 milioni — già esposti nella Parte E. Il nodo specifico del Piemonte è il passaggio dagli attuali incarichi libero-professionali, precari, a un rapporto convenzionale stabile, analogo a quello dei medici di medicina generale, come richiesto dalle rappresentanze professionali; il modello non richiede la creazione di nuove figure e può muovere dalla base già operante.^[139]

I.4 Il caso gestionale: la governance e i rischi

Il caso gestionale riguarda la governance e i rischi. L’attuazione è governata su due livelli: a livello regionale, un comitato di indirizzo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e Ospedaliere, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte, la medicina generale, la pediatria di libera scelta e le università regionali, eventualmente affiancato da una cabina di regia; a livello aziendale, ciascuna Azienda Sanitaria Locale è responsabile dell’attuazione nel proprio ambito, secondo l’indirizzo unitario della Regione.^[140] Il rischio più specifico del Piemonte è la precarietà del servizio attuale, affidato a incarichi dipendenti da rifinanziamenti annuali; ad esso si aggiungono il reclutamento insufficiente, la debole adesione della medicina generale, l’interoperabilità incompleta e la disomogeneità tra le aziende. La principale misura di mitigazione è l’istituzionalizzazione per legge, e il dimensionamento graduale consente di osservare e correggere.^[141] La tabella seguente riepiloga rischi e misure.

Rischio	Natura	Misura di mitigazione
Precarietà del servizio attuale	Base libero-professionale dipendente da rifinanziamenti annuali	Istituzionalizzazione per legge; rapporto convenzionale stabile
Reclutamento insufficiente	Carenza di psicologi formati	Dimensionamento graduale; formazione anticipata
Adesione della medicina generale	Integrazione debole nel percorso	Protocolli di invio; formazione congiunta; governance condivisa
Sistemi informativi	Interoperabilità incompleta	Cartella interoperabile; standard nazionali; infrastruttura regionale
Disomogeneità tra le ASL	Copertura diseguale per effetto della quota capitaria	Algoritmo allocativo; indirizzo regionale; monitoraggio per area

Tabella I.3. I rischi attuativi e le relative misure di mitigazione.

I.5 La sostenibilità finanziaria e le coperture

Il caso finanziario riguarda le coperture e la sostenibilità. Le fonti comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, dell'ordine di 9,5 miliardi di euro, di cui una quota è già destinata al servizio attivo, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'infrastruttura territoriale e digitale, e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali.^[142] Il vincolo di bilancio richiede prudenza: il Piemonte opera sotto pressione finanziaria, pur non essendo in piano di rientro, ma il costo del servizio, anche a massima copertura, costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale del finanziamento, ed essendone già a bilancio una quota, l'investimento incrementale è quello necessario a colmare il divario verso il fabbisogno.^[143] Nel lungo periodo, la leva decisiva della sostenibilità è l'istituzionalizzazione per legge, che sottrarrebbe il servizio alla precarietà dei rifinanziamenti annuali, cui si aggiungono la modestia del costo, il forte ritorno sociale e le economie di scala del coordinamento regionale.^[144] Resta ferma la cautela metodologica già dichiarata: i risultati italiani provengono in parte da letteratura grigia e i benchmark esteri richiedono adattamento, sicché la verifica empirica sui dati regionali, prevista dalla Parte L, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate.^[145] Dimostrate l'attuabilità e la sostenibilità, la parte che segue definisce il sistema di monitoraggio e di valutazione ex post.

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte L

Monitoraggio, valutazione ed ex post

Sistema di indicatori, protocollo e baseline, valutazione controfattuale, verifica ex post, indicatori compositi

Verifica ex post · esperimento naturale e clausola valutativa · fondamento empirico delle stime

Parte L — Monitoraggio, valutazione ed ex post

Questa parte organizza la misurazione dell'intervento nel tempo, ed è il passaggio che distingue una riforma argomentata da una riforma dimostrata. Essa serve ex post i criteri della griglia di giudizio, chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione e, soprattutto, fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti.^{[146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]} Per il Piemonte vale una circostanza peculiare, che merita di essere enunciata: il servizio è già attivo e ha prodotto i primi dati di esito, sicché la misurazione non è da avviare da zero ma da strutturare e completare, e il confronto prima-dopo l'attivazione del 2023, insieme all'eterogeneità dell'intensità di copertura tra le dodici Aziende Sanitarie Locali, offre il fondamento dell'esperimento naturale. Le parti seguenti definiscono gli strumenti: il sistema di indicatori (capitolo L.1), il protocollo che li alimenta e la baseline (L.2), la valutazione controfattuale che ne trae prove causali (L.3), la verifica ex post della norma (L.4) e gli indicatori compositi che ne sintetizzano i risultati nel cruscotto (L.5).

L.1 Il sistema di indicatori

Il sistema di indicatori è costruito sull'ossatura del modello di Donabedian per la qualità dell'assistenza, che distingue le dimensioni di struttura — le risorse e l'organizzazione — di processo — le attività svolte — ed esito — i risultati di salute — qui integrate da una quarta dimensione, l'impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società.^[165] Su questa ossatura si dispone una batteria di circa cinquantotto misure, articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti e dai dati del servizio attivo, e circa quaranta richiedono la rilevazione diretta strutturata.^[166] La selezione delle misure non è arbitraria, ma orientata dal principio della parsimonia: l'iniziativa internazionale per i set di esiti essenziali e i relativi standard individuano, mediante consenso strutturato, un nucleo condiviso e parsimonioso di esiti, evitando la proliferazione di misure ridondanti.^[167] Misurare molto non equivale a misurare bene. La tabella seguente riepiloga le otto categorie e lo stato della rispettiva baseline.^[168]

Categoria	Esempi di indicatori	Baseline
Bisogno e domanda	Prevalenza del disagio, utenza dei servizi, accessi impropri	Disponibile
Accesso ed equità	Tempo di attesa, copertura, divari tra Aziende	Da rilevare
Processo	Sedute erogate, cicli completati, abbandoni	Parziale
Esito clinico	Recupero, miglioramento affidabile, mantenimento	Parziale
Economici	Risparmi per canale, costo per esito	Misto
Impatto sociale	Produttività, benessere, indicatori territoriali	Misto
Organizzativi	Reclutamento, formazione, fedeltà al modello	Da rilevare
Variabili di sintesi	Indici compositi di esito e di valore	Da calcolare

Tabella L.1. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline. Il servizio già attivo fornisce una base parziale di dati di processo ed esito.

L.2 Il protocollo di rilevazione e la baseline

Perché gli indicatori siano calcolabili occorre un protocollo di rilevazione, ed è questo l'elemento operativo che struttura e completa la misurazione già avviata. Il protocollo è minimo — deliberatamente essenziale, per non gravare sull'attività clinica — e attivo dal primo giorno: si registrano la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni.^[169] Gli strumenti di esito sono validati e di uso internazionale: il questionario sulla salute del paziente a nove voci e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci, impiegati — si ribadisce — nei soli punteggi complessivi.^[170] La scelta di raccogliere le misure a ogni seduta, e non solo all'inizio e alla fine, segue il modello dei programmi inglesi: è ciò che consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non protrarre percorsi inefficaci.^[171]

Alla rilevazione si lega la costituzione della baseline, ossia la fotografia dello stato di partenza senza la quale nessun effetto sarebbe misurabile. La baseline si costituisce su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti forniscono la fotografia del prima, cui in Piemonte si aggiunge, quale base preziosa per il confronto prima-dopo, il periodo anteriore all'attivazione del 2023; la rilevazione strutturata di servizio completa quella già avviata.^[172] Il calendario disciplina questa sequenza, dalla costituzione della baseline alla registrazione corrente, alla trasmissione mensile di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale, fino al calcolo periodico delle misure di sintesi e all'aggiornamento del cruscotto.^[173] La tabella seguente lo riepiloga.

Momento	Attività
Baseline (dati disponibili e periodo pre-2023)	Costituzione della fotografia di partenza; valorizzazione del periodo anteriore all'attivazione per il confronto prima-dopo
Rilevazione corrente	Registrazione strutturata di ogni presa in carico e di ogni seduta, con i punteggi di esito
In continuo	Alimentazione del registro; trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale con cadenza mensile
Periodico (semestrale e annuale)	Calcolo delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale

Tabella L.2. Il calendario della rilevazione. In Piemonte il periodo anteriore all'attivazione del 2023 funge da base per il confronto prima-dopo.

L.3 La valutazione controfattuale

Il monitoraggio continuo dice se gli indicatori migliorano; non dice, da solo, se a migliorarli sia stato l'intervento. A questa domanda risponde la valutazione controfattuale d'impatto, che misura l'effetto causale confrontando gli esiti dei trattati con il controfattuale — ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente. Poiché il servizio è già attivo in tutte le Aziende Sanitarie Locali, lo strumento non è il dispiegamento scaglionato, ma il confronto prima-dopo l'attivazione del 2023 e l'eterogeneità dell'intensità di copertura tra le aziende, che insieme configurano un esperimento naturale idoneo a misurare gli effetti reali del servizio.^[174] Il metodo principale è la differenza-nelle-differenze, che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le Aziende a maggiore e a minore intensità di copertura, e prima e dopo l'attivazione, sotto l'ipotesi di andamento parallelo; a esso si affianca il controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata di unità a copertura inferiore.^[175]

L'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e l'effetto medio sui soli trattati, e la sua solidità dipende dalla validità interna — la garanzia che l'effetto sia realmente attribuibile all'intervento e non a tendenze generali — mentre la validità esterna va valutata a parte; i disegni a esperimento naturale sono, per gli interventi di salute della popolazione, lo strumento raccomandato dalla letteratura metodologica.^[176] La portata di questo metodo, per il presente studio, è dirimente: confrontando, ad esempio, l'andamento degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche nelle Aziende a maggiore intensità di copertura con quello delle Aziende a copertura inferiore, e prima e dopo l'attivazione del 2023, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata.^[177] È questo il passaggio che, a regime, eleva lo studio da proposta argomentata a politica validata, e che chiude il cerchio aperto dal valore dell'informazione della Parte F; il Piemonte, disponendo già di un servizio attivo, è nella posizione di compiere questa verifica prima delle altre regioni.

L.4 La verifica ex post della norma

La misurazione tecnica si salda al ciclo della regolamentazione mediante la verifica ex post. La verifica dell'impatto della regolamentazione, disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017, è valutazione ex post — di norma dopo un biennio — dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, e chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione: l'una stima ex ante gli effetti attesi, l'altra ne accerta ex post il conseguimento.^[178] A essa si lega, sul piano regionale, la clausola valutativa, che impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti. La clausola è il passaggio che lega la misurazione tecnica alla responsabilità politica e alla trasparenza verso il legislatore regionale: i risultati non restano negli archivi amministrativi, ma sono portati periodicamente all'attenzione dell'organo che ha disposto il servizio, a presidio della rendicontazione democratica.^[179]

L.5 Gli indicatori compositi e il cruscotto

L'ultima funzione del sistema è la sintesi. La molteplicità degli indicatori, necessaria all'analisi, sarebbe però di difficile lettura per il decisore: gli indicatori compositi riducono tale molteplicità a poche misure di valore complessivo, secondo un metodo codificato. Il manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione delle variabili alla normalizzazione, alla ponderazione e all'analisi di robustezza.^[180] L'impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica ha del resto un precedente istituzionale italiano nel Benessere Equo e Sostenibile, i cui indicatori sono entrati, con la riforma del bilancio del 2016, nel ciclo della programmazione economica.^[181] La costruzione degli indici compositi è retta da regole di coerenza e di non duplicazione: il divieto di doppia contabilizzazione impone che una grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali già adottata nella Parte E.^[182] Il cruscotto regionale, aggiornato periodicamente, restituisce in forma sintetica le dimensioni essenziali — il guadagno di salute, il tasso di recupero, il ritorno sociale, l'equità territoriale, la riduzione delle liste di attesa e gli indicatori di sistema — con il canale della mobilità recuperata in posizione marginale, data la sostanziale condizione di equilibrio del Piemonte. La tabella seguente ne riepiloga le dimensioni.

Dimensione di sintesi	Contenuto
Guadagno di salute	Anni di vita ponderati per la qualità in salute mentale
Tasso di recupero	Miglioramento clinico e superamento delle soglie (PHQ-9, GAD-7)
Ritorno sociale	Valore sociale generato per euro investito (SROI)
Equità territoriale	Esito e accesso tra Aziende Sanitarie Locali e tra area metropolitana e aree interne e alpine
Liste di attesa	Riduzione dei tempi di attesa e tenuta dell'offerta territoriale
Indicatori di sistema	Esito, esperienza, costo e operatori (Quadruple Aim)

Tabella L.3. Le dimensioni di sintesi del cruscotto regionale piemontese.

Definiti gli strumenti della misurazione, lo studio dispone di tutto l'occorrente per accertare nel tempo gli effetti della riforma. La Parte M ne ricompone i risultati in una valutazione multidimensionale e formula le raccomandazioni conclusive.

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Griglia OCSE-DAC, analisi multi-criterio, sintesi del valore e raccomandazioni, limiti e agenda di ricerca

Sintesi conclusiva · caso strategico del Five Case Model · griglia di giudizio OCSE-DAC

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa è la parte conclusiva dello studio, e ha una funzione diversa da tutte le precedenti: non aggiunge una nuova analisi, ma ordina quelle già svolte in un giudizio. Lo strumento di questo giudizio è la griglia dei criteri dell'OCSE-DAC, che attraversa l'intero studio come metro di valutazione e converge qui nella sintesi; la parte fornisce inoltre il contenuto del caso strategico del Five Case Model.^{[183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198]} Le precedenti cornici del telaio dicono che cosa valutare, come decidere e come riportare l'economia; mancava la griglia rispetto alla quale l'intervento è infine giudicato, e la parte la applica (capitolo M.1), la integra con l'analisi multi-criterio per i criteri non monetari (M.2), ne ricava una sintesi del valore e raccomandazioni per il decisore (M.3) e ne dichiara, con franchezza, i limiti e l'agenda di ricerca (M.4).

M.1 La griglia di valutazione OCSE-DAC

I criteri dell'OCSE-DAC sono sei lenti complementari che, insieme, danno un quadro complessivo dell'intervento e dei suoi risultati: la rilevanza rispetto al bisogno, la coerenza con le altre politiche, l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse, l'impatto più ampio e la sostenibilità nel tempo.^[199] Essi operano in due momenti dello studio: ex ante orientano la valutazione complessiva, poiché ciascun

criterio diventa una domanda a cui le parti analitiche forniscono la risposta; ex post strutturano la verifica dei risultati, già trattata nella Parte L. La griglia, in tal modo, non si sovrappone all'analisi economica o ai domini della valutazione di tecnologia sanitaria, ma li ordina in un giudizio.

Applicata a questo studio, la griglia restituisce un giudizio convergente, con una sola qualificazione, propria del caso piemontese, sul criterio dell'efficienza. L'intervento è rilevante, perché risponde a un bisogno reale e di grande dimensione e all'obbligo di garantire i livelli essenziali;^[200] è coerente, perché compatibile con gli standard dell'assistenza territoriale, con il PNRR e con gli atti regionali che già ne hanno previsto la funzione, ed è costituzionalmente difendibile, senza incontrare attualmente il vincolo del piano di rientro;^[201] è efficace, perché l'evidenza internazionale ne documenta il raggiungimento degli obiettivi clinici, corroborata dai primi dati del servizio attivo;^[202] è efficiente in termini di costo-utilità, con dominanza per paziente, pur a fronte di un saldo diretto lievemente negativo sul solo bilancio, di entità modesta;^[203] ha un impatto distributivo favorevole e un ritorno complessivo di 3,8-5,5 a uno;^[204] ed è sostenibile, sul piano finanziario e organizzativo, con l'istituzionalizzazione per legge quale leva decisiva.^[205] La tabella seguente riepiloga il giudizio, criterio per criterio.

Criterio	Domanda valutativa	Giudizio dallo studio
Rilevanza	Risponde al bisogno reale?	Sì: ~850.000 con disagio inevaso; obbligo dei livelli essenziali
Coerenza	È compatibile con le altre politiche?	Sì: DM 77, PNRR, attivazione e rifinanziamenti regionali, legge psicologia scolastica; difendibile in Costituzione; non in piano di rientro
Efficacia	Raggiunge gli obiettivi?	Sì: evidenza internazionale (recupero ~50%) e primi dati del servizio attivo
Efficienza	Impiega le risorse in modo proporzionato?	Sì in costo-utilità (dominanza); saldo diretto lievemente negativo a costo modesto
Impatto	Produce effetti più ampi?	Sì: riduce il gradiente territoriale; ritorno complessivo 3,8-5,5:1
Sostenibilità	I benefici e il servizio durano?	Sì: costo modesto; istituzionalizzazione per legge quale leva; servizio già attivo

Tabella M.1. La griglia di giudizio OCSE-DAC applicata allo studio, criterio per criterio.

M.2 L'analisi multi-criterio

L'analisi costo-efficacia e l'analisi del ritorno sociale esprimono il valore in termini prevalentemente monetari. La decisione pubblica, tuttavia, contempera una pluralità di criteri, alcuni dei quali non riducibili a denaro: l'equità, la fattibilità, la coerenza con gli indirizzi strategici, la solidità dell'evidenza. L'analisi multi-criterio rende esplicito questo bilanciamento, attribuendo a ciascun criterio un peso e a ciascuna opzione un punteggio, e aggregandoli in un punteggio complessivo.^[206] È il metodo che impedisce alla decisione di ridursi alla sola dimensione economica, e che al tempo stesso ne rende trasparente la logica, poiché i pesi e i punteggi sono dichiarati e sindacabili.

Il confronto è condotto tra l'opzione di intervento e l'opzione zero — il mantenimento dello status quo — su otto criteri pesati. Il risultato è netto: l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 81,75 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri a eccezione della sola fattibilità immediata, nella quale l'opzione zero — che non richiede alcuna attuazione — è superiore.^[207] Rispetto al caso

pugliese, nel quale il saldo diretto è positivo, il punteggio dell'intervento è lievemente inferiore, in ragione del saldo diretto negativo che riduce il sub-punteggio dell'impatto di bilancio; la circostanza che il servizio sia già operativo innalza tuttavia il sub-punteggio di fattibilità del Piemonte rispetto agli altri contesti a saldo diretto negativo. Resta una preferenza netta e stabile rispetto ai pesi adottati. La tabella seguente riporta la matrice delle prestazioni.

Criterio	Peso	Interv.	Opz. zero	Δ pond.
Efficacia clinica	15%	80	30	+7,50
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	87	25	+12,40
Impatto di bilancio e sostenibilità	15%	68	50	+2,70
Equità e accesso (aree interne e alpine, età anziana, liste di attesa)	15%	85	20	+9,75
Valore sociale	10%	87	20	+6,70
Fattibilità e implementabilità (servizio già attivo)	10%	84	100	-1,60
Robustezza dell'evidenza (dati operativi propri)	10%	78	60	+1,80
Coerenza strategica (DM 77, PNRR, atti regionali)	5%	90	25	+3,25
Punteggio complessivo ponderato	100%	81,75	39,25	+42,50

Tabella M.2. Analisi multi-criterio: confronto tra l'*****opzione di intervento e l'*****opzione zero su otto criteri pesati.

M.3 La sintesi del valore e le raccomandazioni

La sintesi del valore si lascia condensare in tre affermazioni, che costituiscono il cruscotto decisionale della riforma in Piemonte. La prima: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, dell'ordine di alcune decine di milioni, trascurabile rispetto a un finanziamento dell'ordine di 9,5 miliardi, pur con una salienza diretta non nulla nel contesto delle liste di attesa. La seconda: il ritorno per la collettività è ampio, con un rapporto beneficio-costi dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. La terza: il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali — la produttività, il funzionamento, il minor carico familiare — e non sul risparmio per il bilancio.^[208] È questa la corretta rappresentazione della proposta piemontese: non un investimento che si ripaga sui conti sanitari, ma un investimento sociale ad alto rendimento, il cui costo per il bilancio è trascurabile.

Da questa sintesi discende la raccomandazione centrale, ed è in essa che il caso piemontese si distingue da tutti gli altri. La decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già attiva in tutte le dodici Aziende Sanitarie Locali dal 2023, essendo il Piemonte la prima e inizialmente unica Regione in Italia a renderla operativa — ma se dotarla di una base giuridica stabile, con una legge regionale e un rapporto convenzionale analogo a quello dei medici di medicina generale, e dimensionarla, portandola dalla copertura attuale, dell'ordine del 5% del fabbisogno, alla copertura sistematica, dell'ordine di 700 incarichi nello scenario di base.^[209] La sintesi del valore è letta, infine, lungo le cinque dimensioni del Quintuple Aim — l'esito di salute, l'esperienza della persona, il costo, il benessere degli operatori e l'equità — che ricompongono in un quadro unitario i risultati

delle parti analitiche.^[210] La raccomandazione operativa è di stabilizzare per legge il servizio esistente, convertendo gli incarichi libero-professionali in rapporto convenzionale, e di procedere a un dimensionamento progressivo, avviando contestualmente la rilevazione strutturata e la valutazione controfattuale fondata sul confronto prima-dopo e sull'intensità di copertura.

M.4 I limiti e l'agenda di ricerca

La credibilità di una valutazione si misura anche dalla franchezza con cui ne dichiara i limiti. Il limite principale di questo studio è il radicamento nei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione piemontese, pari al 7,2%, e non estratte dai conti regionali certificati. È una distinzione che lo studio dichiara apertamente, perché la sostituzione di tali ricostruzioni con i valori certificati delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie è la condizione per la presentazione della proposta agli organi di controllo; in Piemonte tale sostituzione è agevolata dalla disponibilità dei dati del servizio già attivo.^[211] A esso si aggiungono cautele di trasferibilità e di fonte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la cifra del ritorno è inoltre prudenziale e non ponderata per l'equità, e potrebbe perciò risultare conservativa.^[212]

Da questi limiti discende l'agenda di ricerca. L'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso le dodici Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliero-Universitarie, seguito dalla strutturazione della rilevazione di servizio e dalla valutazione controfattuale fondata sul confronto prima-dopo l'attivazione del 2023 e sull'intensità di copertura.^[213] È il programma che trasforma progressivamente la proposta argomentata in politica validata, e che salda la valutazione ex ante alla verifica ex post. Con questa parte si chiude lo studio regionale piemontese, che applica al contesto del Piemonte, con piena fedeltà metodologica e con le dovute qualificazioni di onestà, il medesimo telaio integrato già adottato per la Puglia, per la Lombardia, per il Veneto e per l'Emilia-Romagna: un intervento clinicamente fondato, economicamente sostenibile, equo e attuabile, il cui valore per la collettività è ampio e il cui costo per il bilancio è trascurabile, e il cui primato operativo — essendo il Piemonte la prima Regione ad aver reso operativo il servizio — ne fa un riferimento nazionale per la fase di strutturazione e di stabilizzazione per legge.

STUDIO REGIONALE · REGIONE PIEMONTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal primato operativo al servizio strutturato per legge

Appendici A-E

Corredo tecnico e documentale

Caso di riferimento, strumenti di esito, dati regionali, standard di reporting, glossario

Materiali a sostegno delle Parti da A a M

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l'orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità.^{[214][215][216][217][218][219][220][221][222]} La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Servizio attuale o assenza del servizio a regime
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Azienda Sanitaria Locale/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudentiale	Riduzione per l'ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura.^[223] La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato del Piemonte, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.^[224] La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 470	~ 700	~ 920
Costo del servizio	~ 26	~ 38	~ 51
Risparmi diretti (SSR)	~ 16	~ 26	~ 39
Ricadute economico-sociali	~ 83	~ 154	~ 240
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -10	~ -12	~ -12
Saldo complessivo (caso economico)	+73	+142	+228
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,8:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell'esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario.^[225] La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura.^[226] La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori piemontesi impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.^[227]

Ambito	Valore regionale
Popolazione regionale	4.251.868 abitanti (Censimento ISTAT 2024); popolazione sostanzialmente stabile e con marcato invecchiamento
Finanziamento del SSR	Dell'ordine di 9,5 miliardi di euro; sotto pressione finanziaria; nessun piano di rientro in atto; disavanzo storico in restituzione (sent. Corte cost. 87/2024)
Mobilità sanitaria	Saldo sostanzialmente in equilibrio, marginalmente negativo e in peggioramento; polo torinese attivo, province di confine passive
Pronto soccorso	~ 1.300.000 accessi/anno
Farmaceutica	Consumo regionale delle categorie dei psicofarmaci
Salute mentale	~ 850.000 con disagio comune; ~ 56.000 in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale
Funzione attuale	Servizio di psicologia delle cure primarie attivato a livello regionale e operativo da marzo 2023, prima e inizialmente unica Regione; rifinanziato a quota capitaria; oltre 3.000 pazienti e oltre 15.000 prestazioni al 31.12.2023; base libero-professionale; nessuna legge dedicata; ~ 5% del fabbisogno

Tabella C.1. I valori regionali di ancoraggio del Piemonte.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione piemontese, e non estratti dai conti regionali certificati.^[228] La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Dati del servizio attivo	Prese in carico, sedute ed esiti già registrati dal servizio operativo dal 2023
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Azienda Sanitaria Locale e per area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[229] La tabella seguente li riassume.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.^[230] Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra gruppi a diversa esposizione
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità a minore esposizione
Confronto prima-dopo e intensità di copertura	Disegno controfattuale impiegato in Piemonte, ove il servizio è già attivo, in luogo del dispiegamento scaglionato

Termine	Definizione
Analisi e verifica d’impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta a riferire al Consiglio sui risultati della riforma
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell’implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall’impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d’ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l’intensità dell’intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; in Piemonte il saldo è sostanzialmente in equilibrio, marginalmente negativo
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di concentrazione	Misura che lega l’esito di salute alla posizione socio-economica
Peso morto	Quota dell’esito che si sarebbe verificata anche senza l’intervento

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

70

70

Liguria — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Liguria

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all’avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione Liguria sulla riforma «Psicologo di Base». Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell’intero corpus: la premessa, l’indice generale di tutte le parti e di tutte le appendici, la mappa di integrazione delle cornici metodologiche e la sintesi del valore. La Liguria occupa, nel panorama nazionale, una posizione peculiare: ha già istituito il servizio di psicologia territoriale con una legge regionale dedicata — l’articolo 76 della legge 28 dicembre 2023, n. 20 — che ne prevede gli elenchi aziendali, il rapporto convenzionale e un Osservatorio, ma ne ha avviato la sperimentazione soltanto di recente, entro la fine del 2025, dimensionandola in prima applicazione a trentotto psicologi territoriali su base libero-professionale, prioritariamente nelle Case della Comunità Hub, a copertura di una frazione minima del fabbisogno. La decisione rilevante non è dunque se introdurre il servizio, né se dotarlo di una legge, già esistente, ma se condurlo dall’avvio della sperimentazione alla strutturazione a regime e dimensionarlo, dando forma stabile e duratura a una funzione già istituita e appena avviata, nella regione più anziana d’Italia e con la più alta domanda nazionale di salute mentale.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l’alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l’ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell’intero corpus, che può essere percorso nell’ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.3	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, costo-efficacia distributiva, divari territoriali
Parte H	H.1-H.3	Profili etico, giuridico e organizzativo: etico, costituzionale, organizzativo e conformità
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: implementazione, dimensionamento, casi commerciale e gestionale, sostenibilità
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio, valutazione ed ex post: indicatori, protocollo, controfattuale, verifica ex post, cruscotto
Parte M	M.1-M.4	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: griglia OCSE-DAC, analisi multi-criterio, raccomandazioni, limiti
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati regionali e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — lievemente negativo per la Liguria, regione debitrice nella mobilità la cui fuga è però concentrata nelle specialità chirurgiche e non nella domanda psicologica, sicché il canale del recupero della mobilità è solo marginalmente pertinente a questo intervento — e il saldo complessivo, ampiamente positivo. La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 9	~ 14	~ 18
Risparmi diretti (SSR)	~ 6	~ 10	~ 14
Ricadute economico-sociali	~ 29	~ 55	~ 85
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -3	~ -4	~ -4
Saldo complessivo (caso economico)	+26	+51	+81
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,6:1	~5,5:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante non è se prevedere il servizio — già istituito dall’articolo 76 della legge regionale 20 del 2023 e avviato in via sperimentale — né se dotarlo di una legge, già esistente, ma se condurlo dall’avvio della sperimentazione alla strutturazione a regime, stabilizzando il rapporto convenzionale previsto dalla legge, e dimensionarlo, portandolo dalla copertura attuale, dell’ordine del tre-quattro per cento del fabbisogno, alla copertura sistematica, dell’ordine di 250 incarichi nello scenario di base e di 330 in quello espansivo. Il limite principale è il radicamento dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione ligure, del 2,6%, e non estratte dai conti regionali certificati delle cinque Aziende Socio-sanitarie Liguri e degli IRCCS; la loro sostituzione con dati certificati è la condizione per la presentazione agli organi di controllo, ed è in Liguria, a differenza della Toscana, ancora poco mitigata da dati operativi, poiché la sperimentazione è appena avviata.

Lo studio si fonda, sul piano comparativo, sui programmi internazionali più autorevoli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie — il programma inglese di terapie psicologiche, il modello olandese, l’iniziativa australiana e il Collaborative Care statunitense — dei quali mutua le evidenze di efficacia e di costo-efficacia, adattandole con cautela al contesto ligure. La condizione propria della Liguria — una legge regionale già vigente unita a una sperimentazione che muove i primi passi e si dispiegherà progressivamente tra le cinque Aziende — le conferisce un pregio metodologico peculiare: la possibilità di disegnare fin dall’avvio una valutazione controfattuale a cunei progressivi, la più pulita realizzabile nella serie regionale, capace di trasformare le stime in prove via via che il servizio si estende. Su questa base, e con la dichiarazione trasparente dei propri limiti, il corpus consegna al decisore un quadro completo e onesto su cui deliberare.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LIGURIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all’avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell’HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per la Liguria, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna, al Piemonte e alla Toscana. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati alla Liguria. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). È la parte che rende lo studio insieme rigoroso, riproducibile e confrontabile con quelli pugliese, lombardo, veneto, emiliano-romagnolo, piemontese e toscano e con quelli delle altre Regioni.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Servizio di Psicologia di Base nelle cure primarie della Liguria, inteso come strutturazione a regime di una funzione che la regione ha già istituito con una legge dedicata — la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20, che all'articolo 76 istituisce il servizio di psicologia territoriale — e di cui ha avviato la sperimentazione entro la fine del 2025, nelle Case della Comunità e in integrazione con la medicina generale, in prima applicazione con trentotto psicologi territoriali.^[231] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sul condurre il servizio a regime. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già istituita per legge — né se dotarla di una base giuridica, già esistente, ma se portare la sperimentazione appena avviata fino alla strutturazione a regime: la cornice normativa esiste e la sperimentazione muove i primi passi, ma la stabilizzazione del rapporto convenzionale, l'estensione a tutte le Case della Comunità e una copertura adeguata sono ancora da definire, a fronte di un fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 330 psicologi. Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 300.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale, in un quadro segnato da componenti convergenti — il bisogno dell'età anziana, massimo nella regione più anziana d'Italia e accentuato nell'entroterra appenninico, il disagio connesso al lavoro, il disagio giovanile e una componente straniera intorno all'undici per cento — e, soprattutto, dal primato nazionale della prevalenza di utenti trattati dai servizi di salute mentale, cui si aggiunge la pressione delle liste di attesa. La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti liguri con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è lo psicologo di base nelle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, portato a regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale il servizio è già istituito per legge ma la sperimentazione è appena avviata, su base libero-professionale e a copertura minima. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario della Liguria, con le sue cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, l'Azienda Ligure

Sanitaria quale agenzia regionale di coordinamento, gli IRCCS San Martino e Gaslini, gli enti ospedalieri Galliera ed Evangelico e la rete delle Case della Comunità. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per la Liguria
Popolazione	Residenti liguri con disagio psichico comune (~300.000); in seconda istanza l’intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Psicologo di base nelle cure primarie, primo livello e filtro, portato a regime (~170/250/330 incarichi); strutturazione e dimensionamento del servizio già istituito per legge e in sperimentazione
Confronto	Condizione attuale: servizio istituito con la legge regionale 20 del 2023 e con sperimentazione appena avviata (trentotto psicologi territoriali), su base libero-professionale, a copertura minima del fabbisogno
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale della Liguria; cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa), IRCCS San Martino e Gaslini, enti ospedalieri Galliera ed Evangelico, rete delle Case della Comunità

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell’HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell’OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l’intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l’insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e la condizione attuale come comparatore. Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Aziende Sociosanitarie Liguri e i distretti sanitari, per dare conto anche dei divari territoriali interni tra la fascia costiera e l’entroterra appenninico.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale, ovvero servizio istituito per legge con sperimentazione appena avviata su base libero-professionale, non ancora strutturato a regime né dimensionato
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda Sociosanitaria Ligure e distretto sanitario
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. Tale prudenza assume, per la Liguria, un rilievo particolare e una qualificazione propria: il saldo di mobilità sanitaria è passivo, dell'ordine di settanta milioni di euro e in peggioramento, ma la fuga è concentrata nelle specialità chirurgiche — ortopedia, cardiologia, malattie del sistema nervoso — e non nella domanda psicologica delle cure primarie. Poiché lo psicologo di base agisce su un bisogno diverso da quello che genera la fuga, il canale del recupero della mobilità, leva centrale per le regioni debitrici del Mezzogiorno, in Liguria è solo marginalmente pertinente a questo intervento. Ne consegue che il saldo diretto risulta lievemente negativo e che il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, che lo studio stima con criteri conservativi; in un contesto di pressione finanziaria e di primato nazionale della domanda di salute mentale, peraltro, il contenimento della domanda impropria conserva una salienza diretta. Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati, e che in Liguria, a differenza della Toscana, la sperimentazione è troppo recente per mitigare la lacuna con dati operativi maturi.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post. Per la Liguria il disegno controfattuale assume una forma propria e particolarmente solida: poiché la sperimentazione è in fase di avvio e si dispiega progressivamente tra le cinque Aziende e i loro distretti, l'effetto causale può essere stimato da un esperimento a cunei progressivi pianificato prospetticamente, con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico, sfruttando l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi e l'eterogeneità dell'intensità di copertura. La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, le cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, l'Azienda Ligure Sanitaria, gli IRCCS San Martino e Gaslini, gli enti ospedalieri Galliera ed Evangelico, l'Ordine degli Psicologi della Liguria, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e l'Università di Genova, nonché all'Osservatorio previsto dalla legge regionale. A differenza del Veneto, la Liguria non dispone di un'azienda regionale unica, ma l'Azienda Ligure Sanitaria svolge funzioni regionali di coordinamento, programmazione e governo del sistema, sicché il veicolo per una progettazione unitaria e un'attuazione omogenea è disponibile. Poiché il servizio è già istituito per legge, e la rete territoriale delle Case della Comunità costituisce l'infrastruttura su cui esso si innesta, la sfida del governo è di condurre a regime e dimensionare un servizio la cui sperimentazione è appena avviata, definendone l'ordine di attivazione tra le Aziende: è il tratto che distingue la Liguria e che la valutazione assume come punto di partenza.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto della Liguria.

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all'avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi e cornice normativa

Primo dominio dell'HTA · il problema di salute e il suo contesto

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto della Liguria. La struttura è quella già adottata per la Puglia, per la Lombardia, per il Veneto, per l'Emilia-Romagna, per il Piemonte e per la Toscana, e mutano soltanto i dati, ancorati alla regione. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall'epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l'intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico della Liguria: non un sistema da introdurre ex novo, né un servizio operante senza una legge, ma un servizio già istituito da una legge regionale dedicata e la cui sperimentazione è appena avviata, che attende di essere condotto a regime e dimensionato al fabbisogno, nella regione più anziana d'Italia e con la più alta domanda nazionale di salute mentale.

B.1 Quadro demografico

La Liguria conta 1.510.143 residenti, pari a circa il 2,6% della popolazione nazionale, in lievissimo aumento ma soltanto grazie alle migrazioni, che compensano un saldo naturale fortemente negativo. La struttura per età è la più anziana d'Italia: l'indice di vecchiaia è il più elevato del Paese e la quota di ultrasessantacinquenni si avvicina al trenta per cento, mentre l'aspettativa di vita resta in linea con la media nazionale; Genova è tra le aree più anziane d'Europa. La componente straniera, pari al 10,8%, è superiore alla media nazionale, ed è proprio il flusso migratorio a sostenere la popolazione e a frenarne l'invecchiamento. Il territorio si articola in quattro province, con più della metà dei residenti nella sola Città Metropolitana di Genova e una marcata variabilità interna fra la fascia costiera e l'entroterra appenninico in spopolamento. La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per la Liguria
Popolazione (Censimento 2024)	1.510.143 (~2,6% del totale nazionale); +0,1%, solo per saldo migratorio
Aspettativa di vita	~ 81 anni (uomini) e ~ 85 (donne), in linea con la media nazionale
Età media e invecchiamento	~ 49,6 anni; la struttura più anziana d'Italia; indice di vecchiaia ~ 277; over-65 ~ 29%
Componente straniera	10,8% dei residenti, superiore alla media nazionale; sostiene la popolazione
Articolazione del territorio	Quattro province; Città Metropolitana di Genova 54,2%
Profilo territoriale	Stretta fascia costiera e entroterra appenninico anziano e in spopolamento
Articolazione sanitaria	Cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, Azienda Ligure Sanitaria, IRCCS ed enti ospedalieri

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico della Liguria.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale in Liguria è elevato e sospinto da un profilo demografico estremo. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali sulla popolazione regionale, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell'ordine di 300.000 persone, in larga parte non intercettate dall'offerta strutturata. Il tratto più marcato è però che la Liguria registra la più alta prevalenza italiana di utenti in carico ai servizi specialistici di salute mentale, a fronte di una dotazione di strutture territoriali sotto la media e di una carenza strutturale della figura dello psicologo. Tre componenti orientano la domanda. La prima è il disagio giovanile, in crescita. La seconda è il disagio connesso al lavoro nella popolazione attiva. La terza, e più caratteristica, è il bisogno dell'età anziana, massimo nella regione più anziana d'Italia e accentuato nell'entroterra. È la combinazione — invecchiamento estremo, primato nazionale della domanda di salute mentale e una legge già vigente con una sperimentazione appena avviata — a distinguere il fabbisogno ligure. La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche elevati e superiori alla media nazionale.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone un'offerta che, in Liguria, presenta una fisionomia peculiare: il servizio di psicologia territoriale è già istituito da una legge regionale dedicata, ma la sperimentazione è appena avviata, dimensionata in prima applicazione a trentotto psicologi su base libero-professionale, prioritariamente nelle Case della Comunità Hub. Il fabbisogno a regime è stimato nell'ordine di 330 psicologi, e l'Ordine professionale regionale ne sostiene la conduzione a regime con un rapporto convenzionale stabile. La copertura attuale è dunque minima, dell'ordine del tre-quattro per cento: non l'assenza di un servizio, né una funzione solo amministrativa, ma un servizio reale, fondato su una legge e con una sperimentazione ai primi passi, da condurre a regime e dimensionare. La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per la Liguria
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 300.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	~ 58.000 (la più alta prevalenza d'Italia)
Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche	~ 20.000 l'anno (sopra la media nazionale)
Offerta territoriale attuale	Servizio istituito per legge (L.R. 20/2023, art. 76) con sperimentazione appena avviata (trentotto psicologi), su base libero-professionale, nelle Case della Comunità Hub
Fabbisogno stimato a regime	~ 330 psicologi (310-350)
Copertura attuale del fabbisogno	Minima, dell'ordine del 3-4% del bisogno potenziale

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, in Liguria, si gioca soprattutto sull'asse fra la costa e l'entroterra. Da un lato la stretta fascia costiera, dove si concentrano la popolazione e i poli sanitari di eccellenza; dall'altro l'entroterra appenninico, anziano, disperso e in spopolamento, dove l'accesso ai servizi è reso difficile dalla conformazione vallata e montana e dalla rarefazione dell'offerta. A questo asse si aggiunge la pressione delle liste di attesa, comune all'intera regione. Su questi divari il servizio di psicologia di base agisce in funzione di equità: avvicina l'offerta alle aree interne mediante la telepsicologia assistita — dove la sola presenza di un primo livello accessibile è già un atto di riequilibrio — e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica e contribuisce a contenere i tempi di attesa, in una regione in cui la domanda di salute mentale è la più alta d'Italia.

B.5 I servizi e i flussi

Il Servizio sanitario della Liguria dispone di risorse complessive dell'ordine di 3,5 miliardi di euro; la Regione non è soggetta a un piano di rientro, ma presenta un disavanzo strutturale coperto con risorse regionali e opera sotto pressione finanziaria, con la riduzione delle liste di attesa indicata come priorità e un ricorso al privato accreditato tra i più contenuti d'Italia. A differenza delle regioni creditrici, la Liguria presenta un saldo di mobilità passivo e in peggioramento, ma con una qualificazione dirimente: la fuga è concentrata nelle specialità chirurgiche e non nella domanda psicologica, sicché il canale del recupero della mobilità è solo marginalmente pertinente a questo intervento. L'architettura dei servizi poggia su cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, sull'Azienda Ligure Sanitaria quale agenzia regionale di coordinamento, sugli IRCCS San Martino e Gaslini e sugli enti ospedalieri Galliera ed Evangelico, e su una rete territoriale costituita dalle Case della Comunità, su cui il servizio si innesta. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per la Liguria
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	~ 3,5 miliardi di euro; non in piano di rientro; disavanzo strutturale coperto con risorse regionali; sotto pressione finanziaria
Mobilità sanitaria	Saldo passivo (~ -70 milioni) e in peggioramento; fuga in specialità chirurgiche; canale marginale come leva per questo intervento
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche dell'ordine di ventimila l'anno, sopra la media nazionale
Architettura dei servizi	Cinque ASL, Azienda Ligure Sanitaria, IRCCS San Martino e Gaslini, enti ospedalieri Galliera ed Evangelico; rete delle Case della Comunità
Margine di azione principale	Liste di attesa, strutturazione e dimensionamento del servizio già istituito per legge, accesso dell'entroterra, primato della domanda di salute mentale

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice peculiare: la Liguria ha già istituito il servizio con una legge regionale dedicata — l'articolo 76 della legge 20 del 2023 — che prevede elenchi aziendali di psicologi territoriali, almeno due psicologi per distretto, un rapporto convenzionale su base libero-professionale e la costituzione di un Osservatorio con funzioni di controllo, programmazione e indirizzo, ammettendo in prima applicazione gli psicologi con esperienza almeno biennale. Sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera, il Piano Nazionale per la Salute Mentale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — che ha confermato la competenza regionale in materia — compongono il quadro di riferimento. La decisione rilevante, in questo contesto, non è introdurre la funzione né dotarla di una legge, già esistente, ma condurre a regime e dimensionare una sperimentazione appena avviata: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LIGURIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all'avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte C

L'intervento e il suo modello

Definizione, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali e formazione

Secondo dominio dell'HTA · la descrizione della tecnologia

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico della

Liguria emerge con nettezza: l'intervento non è da introdurre, ma è già istituito per legge e la sua sperimentazione è appena avviata, e si tratta di condurlo a regime e di dimensionarlo, potendo per giunta progettarne fin dall'inizio il modello e il monitoraggio.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire. La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria, ossia dell'intercettare prima che il disturbo si cronicizzi. Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell'ordine di 300.000 persone con disagio comune. La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per la Liguria
Bisogno	~ 300.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Psicologo nelle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, e minor carico familiare, particolarmente rilevante nella popolazione anziana
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo di base nelle Case della Comunità, prioritariamente di tipo Hub, in collaborazione con i medici di medicina generale e secondo quanto previsto dalla legge regionale. La Liguria presenta qui una specificità: la sperimentazione è in fase di avvio nelle cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, con almeno due psicologi territoriali per distretto. A differenza del Veneto, la regione non dispone di un'azienda regionale unica, ma l'Azienda Ligure Sanitaria svolge funzioni regionali di coordinamento, programmazione e governo, sicché l'omogeneità attuativa e le economie di scala sono assicurate a livello regionale, affiancate dall'Osservatorio previsto dalla legge. La rete territoriale delle Case della Comunità è l'infrastruttura su cui il servizio si innesta, e il compito non è crearla ma estendere su di essa il servizio in modo uniforme. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista — nella forma già prevista per la sperimentazione — una valutazione iniziale con progetto clinico individuale, un ciclo di colloqui brevi con programma di sostegno

personalizzato e, nei casi che lo richiedono, l’invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti. Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d’ansia generalizzata. Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell’attività e degli esiti, integrata con il fascicolo sanitario elettronico regionale, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. In coerenza con l’assetto di governo descritto, il coordinamento informativo è in capo all’Azienda Ligure Sanitaria, che ne assicura l’uniformità fra le cinque Aziende. La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale; su questo terreno la Liguria dispone di un vantaggio peculiare e opposto a quello toscano: poiché la sperimentazione è appena avviata, il flusso informativo può essere progettato fin dal primo giorno in modo completo e uniforme, senza dover recuperare a posteriori dati frammentari.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l’indirizzamento e l’individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale. Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile. L’automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica. La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, in Liguria, lo strumento per garantire l’accesso nell’entroterra appenninico, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza. I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici. La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d’impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nell'entroterra appenninico; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso l'Università di Genova; il livello post-universitario specialistico attraverso un corso semestrale regionale abilitante — già previsto dalla legge regionale, con attestato rilasciato dalla Regione — dedicato alla psicologia di base e alle cure primarie e comprensivo della competenza per l'età anziana, per l'entroterra e della competenza culturale per l'utenza straniera, particolarmente rilevanti nel contesto ligure; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione. A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità, sostenuta dall'infrastruttura informatica regionale. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Università di Genova
2. Post-universitario specialistico	Psicologia di base e cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, competenza per l'età anziana e culturale	Corso semestrale regionale abilitante (previsto dalla legge)
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LIGURIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all'avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte D

Efficacia clinica ed evidenza

Metodo della revisione, evidenza di efficacia, qualità GRADE, benchmark internazionali, trasferibilità

Quarto dominio dell'HTA · l'efficacia clinica

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte affronta il quarto dominio della valutazione, l'efficacia clinica, e ne ricostruisce la base di evidenza. Come per le regioni precedenti, il corpo dell'evidenza internazionale è invariante, poiché l'efficacia di un intervento clinico non muta con i confini regionali; muta invece la base di evidenza locale, ed è qui che la Liguria si distingue. La parte espone il metodo della revisione e i risultati di efficacia (capitolo D.1); ne gradua la qualità e ne dichiara una cautela economica essenziale (D.2); presenta i benchmark internazionali (D.3); e discute le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale ligure (D.4). Quest'ultima presenta un tratto opposto a quello toscano: poiché la sperimentazione ligure è appena avviata, lo studio si fonda, per l'efficacia, in misura maggiore sui benchmark internazionali e sul disegno valutativo prospettico, e in misura minore su dati italiani già disponibili.

D.1 Il metodo della revisione e l'evidenza di efficacia

La sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale, con preferenza per le fonti più recenti. Il nucleo dell'evidenza proviene dal modello della cura collaborativa, di cui lo studio fondativo ha documentato che circa la metà dei pazienti trattati conseguiva una riduzione sostanziale dei sintomi a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura usuale. La robustezza del risultato è confermata dalla meta-analisi su cinquantasette studi controllati, con un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a poco meno di un terzo di deviazione standard, e da una più recente revisione di quarantadue implementazioni, che documenta riduzioni rilevanti della depressione e dell'ansia e una contrazione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri. Sul versante dei dati reali, il programma inglese delle terapie psicologiche registra, su scala di oltre un milione di persone l'anno, un tasso di recupero del 50,2% e un miglioramento affidabile di oltre due terzi, con completezza dei dati di esito superiore al 98%. Anche le sintesi più caute confermano un effetto di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante sull'intera popolazione.

D.2 La qualità dell'evidenza e una cautela economica

La graduazione della certezza secondo il sistema GRADE colloca l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie su un livello da moderato a elevato per i disturbi comuni, mentre la certezza è più eterogenea e minore per gli esiti economici, in particolare per quelli di sistema. Da questa graduazione discende una cautela che lo studio adotta come principio di onestà intellettuale, e che merita di essere enunciata senza attenuazioni: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero. Ciò significa che il valore economico del modello non può essere fondato sui risparmi sanitari diretti, ma poggia in misura preponderante sui ritorni sociali. È una cautela che, lungi dall'indebolire il caso ligure, ne corrobora la coerenza interna, poiché il caso economico della Liguria — come si vedrà nella Parte E — è fondato anch'esso sulle ricadute sociali, e non su un risparmio diretto che la regione, creditrice o debitrice che sia, non potrebbe rivendicare con certezza statistica.

D.3 I benchmark internazionali

L'evidenza si concretizza in quattro programmi nazionali consolidati, che costituiscono i riferimenti per il disegno del servizio. Il programma inglese delle terapie psicologiche è il riferimento principale per l'organizzazione: servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50% e monitoraggio degli esiti pressoché completo. Il modello olandese integra una figura di supporto psicologico nello studio del medico di base, adottata dalla maggioranza dei medici, con ruolo complementare alla specialistica. Il modello australiano, a invio esterno, ha innalzato di oltre dieci punti la quota di popolazione in trattamento. Il modello statunitense della cura collaborativa, validato da oltre novanta studi controllati, documenta riduzioni rilevanti della depressione e dei ricoveri. La tabella seguente ne riepiloga i tratti salienti.

Programma	Modello	Risultati principali
Regno Unito (NHS Talking Therapies)	Servizio integrato a intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio esiti >98%; >1,3 milioni/anno
Paesi Bassi (POH-GGZ)	Supporto psicologico nello studio del medico di base	Adozione da ~tre quarti dei medici; ruolo complementare
Australia (Better Access)	Invio esterno a professionisti	Popolazione in trattamento dal 35% al 46%
Stati Uniti (Collaborative Care)	Équipe integrata con monitoraggio	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione, -41% ricoveri

Tabella D.1. I benchmark internazionali dell'integrazione della salute mentale nelle cure primarie.

D.4 Le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale

Sul piano nazionale, diverse sperimentazioni locali — fra cui quelle riconducibili al modello di Solano nel Lazio — hanno anticipato l'integrazione psicologica nelle cure primarie, e ad esse si aggiungono oggi i servizi avviati nelle regioni dotate di una legge dedicata, tra cui la Liguria; i dati delle sperimentazioni storiche derivano però da campioni limitati e in parte da letteratura grigia, e vanno assunti con cautela. Più in generale, i risultati internazionali provengono da sistemi diversi per organizzazione e finanziamento, e la loro trasposizione richiede validazione locale, evitando di trasferire meccanicamente le stime, soprattutto quelle economiche. È qui che la posizione della Liguria si distingue da quella toscana, e va dichiarata con franchezza: a differenza della Toscana, dove una sperimentazione già matura fornisce dati di esito reale, in Liguria la sperimentazione è appena avviata e non ha ancora prodotto dati propri, sicché l'evidenza locale è allo stato prospettica. Ciò non costituisce, tuttavia, soltanto un limite: pur non disponendo ancora di dati operativi, la Liguria presenta un terreno favorevole alla valutazione — l'infrastruttura informatica regionale, la rete delle Case della Comunità, il coordinamento dell'Azienda Ligure Sanitaria — e gode del vantaggio di poter disegnare la valutazione fin dall'avvio del servizio, generando un'evidenza locale solida e non soltanto importata. Una precisazione di metodo, infine, accompagna l'intero studio a garanzia della sua credibilità. Alcune cifre di larga circolazione — il rapporto di quattro a uno, l'affermazione per cui un euro ne genererebbe dieci, il rapporto di due e mezzo a uno talvolta richiamato in sede regionale — sono semplificazioni divulgative. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, e lo studio adotta prudenzialmente un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,8 a 5,5 a uno. Su questa base di evidenza, graduata e dichiarata nei suoi limiti, poggia la valutazione economica della Parte E.

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all’avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte E

La valutazione economica

Costi, esiti, costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario

Quinto dominio dell’HTA · la valutazione economica

Parte E — La valutazione economica

Questa parte costituisce il cuore quantitativo dello studio e ne sviluppa il quinto dominio: la valutazione economica. La struttura ricalca quella adottata per le altre regioni e ne condivide il metodo, mentre i valori sono ancorati alla Liguria. La parte identifica e stima i costi del servizio (capitolo E.1) e gli esiti di salute (E.2); ne ricava il costo-utilità (E.3); analizza l’impatto sul bilancio sanitario per canali di risparmio (E.4); stima il ritorno sociale per la collettività (E.5); e ricompone il quadro nei casi economico e finanziario del Five Case Model, con la valutazione di sostenibilità (E.6). Tutti i valori sono espressi a regime e per tre scenari di copertura. La chiave di lettura, anticipata sin d’ora, è la distinzione tra il saldo diretto per il bilancio — lievemente negativo — e il ritorno per la collettività — ampiamente positivo — in una regione che, pur debitrice nella mobilità, non può contare su tale canale per il pareggio diretto, poiché la fuga è chirurgica e non psicologica.

E.1 Identificazione e stima dei costi

Il costo del servizio comprende le remunerazioni dei professionisti, i costi organizzativi e di coordinamento e la quota destinata alla formazione congiunta, ed è stimato per scenario di copertura ed espresso a regime. In termini aggregati, esso è dell’ordine di 9 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 14 nello scenario base e 18 nello scenario espansivo, valori che già incorporano il programma di formazione, inclusa la componente sull’intelligenza artificiale. La stima muove da un valore unitario per incarico dell’ordine di 55.000 euro annui, regionalizzato in proporzione alla popolazione e al numero di professionisti; va ricordato che la sperimentazione è oggi finanziata su base libero-professionale per un importo dell’ordine di due milioni di euro, che copre una frazione minima del fabbisogno. La tabella seguente riporta il costo per scenario, raccordato al fabbisogno di professionisti.

Voce	Conserv.	Base	Espans.
Psicologi a regime (incarichi)	~ 170	~ 250	~ 330
Costo unitario per incarico	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Costo del servizio (mln €/anno)	~ 9	~ 14	~ 18
Copertura del fabbisogno	Parziale	Ampia	Piena

Tabella E.1. Il costo del servizio per scenario di copertura, a regime.

E.2 Identificazione e misura degli esiti

Gli esiti di salute sono espressi in anni di vita ponderati per la qualità e in esiti clinici validati; i tassi di recupero e di miglioramento sono desunti dai benchmark consolidati discussi nella Parte D e applicati in via prudenziale al contesto ligure. Le misure impiegate, nei soli punteggi complessivi, sono il questionario a nove voci sui

sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia, con un tasso di recupero di riferimento dell'ordine del cinquanta per cento, in linea con il programma inglese. La scelta di adottare valori prudenziali, inferiori ai massimi osservati nei programmi più efficienti, è coerente con la correzione per l'ottimismo dichiarata nella Parte A e mira a non sovrastimare i benefici.

E.3 Costo-efficacia e costo-utilità

Dal rapporto tra i costi e gli esiti di salute discende il giudizio di costo-efficacia. Il costo per anno di vita ponderato per la qualità si colloca al di sotto della soglia comunemente adottata, fissata per riferimento nell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, in linea con la prassi internazionale. L'analisi per paziente, sviluppata in dettaglio nella Parte F mediante il modello di Markov, indica condizioni di dominanza dell'intervento rispetto all'opzione di non intervento, ossia un intervento che a un tempo migliora gli esiti e riduce i costi attesi lungo l'intero orizzonte temporale considerato. Il giudizio di costo-efficacia è, in altri termini, favorevole già sul piano della sola costo-utilità, prima ancora di considerare le ricadute sociali.

E.4 L'impatto sul bilancio

L'analisi di impatto sul bilancio misura i risparmi diretti per il Servizio sanitario regionale, articolati nei canali del pronto soccorso, della farmaceutica e dei ricoveri e prestazioni specialistiche evitabili. Qui la Liguria presenta una specificità che lo studio dichiara con franchezza: la regione è debitrice nella mobilità, con un saldo passivo dell'ordine di settanta milioni di euro, ma la fuga è concentrata nelle specialità chirurgiche e non nella domanda psicologica, sicché il canale della mobilità recuperata — leva centrale per le regioni debentrici del Mezzogiorno come la Puglia — è in Liguria solo marginalmente pertinente a questo intervento e vi figura per un importo simbolico. I risparmi diretti complessivi sono pertanto stimati, in via prudenziale, nell'ordine di 6 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 10 nel base e 14 nell'espansivo, con il canale della mobilità in posizione marginale. Ne consegue un saldo diretto per il bilancio sanitario — differenza tra risparmi diretti e costo del servizio — dell'ordine di -3, -4 e -4 milioni di euro annui nei tre scenari, lievemente negativo. Questo saldo negativo è dichiarato senza attenuazioni e ne costituisce il profilo onesto: a differenza della Puglia, in Liguria la fuga è chirurgica e il valore risiede nelle ricadute sociali, ma in un contesto di pressione finanziaria e di primato nazionale della domanda di salute mentale il contenimento della domanda impropria conserva una salienza diretta non trascurabile. La tabella seguente disaggrega i risparmi diretti per canale.

Canale di risparmio diretto	Conserv.	Base	Espans.
Pronto soccorso	~ 1	~ 2	~ 2
Farmaceutica	~ 1	~ 2	~ 3
Ricoveri e specialistica evitabili	~ 3	~ 5	~ 8
Mobilità recuperata (marginale)	~ 1	~ 1	~ 1
Risparmi diretti totali (mln €/anno)	~ 6	~ 10	~ 14

Tabella E.2. I risparmi diretti per il Servizio sanitario regionale, per canale; il canale della mobilità è marginale perché la fuga ligure è chirurgica.

E.5 Il ritorno sociale

Il valore dell'intervento che eccede il bilancio sanitario è colto dall'analisi del ritorno sociale, che ne monetizza le ricadute per la collettività: la maggiore produttività recuperata, la riduzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, le efficienze nel sistema dei servizi di salute mentale e il sollievo alle figure di cura familiari. Nella regione più anziana d'Italia, a fortissima presenza di cronicità e con la più alta prevalenza nazionale di utenti dei servizi di salute mentale, le componenti della produttività recuperata e del sollievo ai familiari assumono un peso particolarmente elevato. Le ricadute economico-sociali sono stimate, con criteri conservativi, nell'ordine di 29 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 55 nel base e 85 nell'espansivo. Sommando i risparmi diretti e le ricadute sociali si ottiene il ritorno complessivo, dell'ordine di 35, 65 e 99 milioni di euro annui, da cui un saldo complessivo, al netto del costo del servizio, dell'ordine di +26, +51 e +81 milioni di euro annui. Il rapporto beneficio-costi complessivo è conseguentemente dell'ordine di 3,9 a uno nello scenario conservativo, 4,6 a uno nel base e 5,5 a uno nell'espansivo, in linea con il valore validato sulle altre regioni e con le stime fondate della letteratura.

E.6 Caso economico, caso finanziario e sostenibilità

La ricomposizione dei risultati secondo il Five Case Model distingue due grandezze che non vanno confuse. Il caso finanziario, riferito al solo bilancio sanitario, presenta un saldo diretto lievemente negativo; il caso economico, riferito alla collettività, è ampiamente positivo. La distinzione tra le due grandezze è la chiave dell'intera analisi, e vale per la Liguria come per le altre regioni a saldo diretto negativo. Sul piano della sostenibilità finanziaria, il costo del servizio si colloca nell'ordine dello 0,3-0,5% di un Fondo Sanitario Regionale dell'ordine di 3,5 miliardi di euro: benché la regione operi sotto pressione finanziaria e con un disavanzo strutturale coperto con risorse regionali, l'importo è contenuto, tanto più che una quota è già a bilancio per la sperimentazione avviata, e l'investimento incrementale è quello necessario a colmare il divario verso il fabbisogno. Resta da dichiarare, con la stessa franchezza adottata per il saldo diretto, la lacuna prioritaria: le grandezze economiche qui impiegate sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti regionali certificati delle cinque Aziende e degli IRCCS, e in Liguria, a differenza della Toscana, tale ricostruzione è ancora poco mitigata da dati operativi, poiché la sperimentazione è appena avviata. La tabella seguente ricompone il quadro economico consolidato per scenario.

Componente (mln €/anno)	Conserv.	Base	Espans.
Costo del servizio	~ 9	~ 14	~ 18
Risparmi diretti (SSR)	~ 6	~ 10	~ 14
Ricadute economico-sociali	~ 29	~ 55	~ 85
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -3	~ -4	~ -4
Saldo complessivo (caso economico)	+26	+51	+81
Rapporto beneficio-costi complessivo	~3,9:1	~4,6:1	~5,5:1

Tabella E.3. Il quadro economico consolidato per scenario; la distinzione tra saldo diretto e saldo complessivo è la chiave di lettura.

Definito il quadro economico, resta da darne conto sotto il profilo dell'incertezza: la parte che segue sviluppa la modellazione e l'analisi di sensibilità, per stabilire quanto i risultati siano robusti alla variazione dei parametri.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LIGURIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all'avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte F

Modellazione e incertezza

Modello di Markov, caso base e dominanza, analisi di sensibilità, analisi probabilistica, valore dell'informazione

Quinto dominio dell'HTA · modellazione e governo dell'incertezza

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte completa il quinto dominio sviluppando i metodi di modellazione e di gestione dell'incertezza, a fondamento delle stime economiche della Parte E. Il modello e i suoi risultati per paziente sono, per costruzione, indipendenti dalla regione, e sono pertanto i medesimi validati per le altre Regioni; muta invece, ed è il punto qualificante per la Liguria, la strategia di calibrazione e di verifica empirica. La parte presenta il modello e il suo metodo (capitolo F.1); ne espone il caso base e la condizione di dominanza (F.2); ne analizza la sensibilità a una via e strutturale (F.3); ne sviluppa l'analisi probabilistica (F.4); e ne deriva il valore dell'informazione e il disegno della verifica empirica (F.5). Quest'ultimo riserva alla Liguria un vantaggio peculiare: poiché la sperimentazione è appena avviata, la verifica può essere disegnata prospetticamente, come un esperimento a cunei progressivi pianificato fin dall'inizio.

F.1 Il modello e il suo metodo

La modellazione segue le buone pratiche di ricerca riconosciute ed è riportata secondo lo standard CHEERS 2022.^{[232][233][234]} Lo strumento è un modello di Markov a coorte, che rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come una successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi — sintomatico, recupero, cronico, morte — scanditi da cicli con correzione di metà ciclo, affiancato dalla microsimulazione per le traiettorie individuali.^[235] È lo strumento standard della valutazione economica in sanità per gli interventi i cui effetti si dispiegano nel tempo, e consente di proiettare costi ed esiti lungo l'orizzonte quinquennale adottato.

F.2 Il caso base e la dominanza

Nel caso base, riferito a un singolo paziente su un orizzonte di cinque anni e a valori scontati, il braccio dell'intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un'utilità di 3,627 anni di vita ponderati per la qualità, contro un costo di circa 3.799 euro e un'utilità di 3,392 dell'assistenza usuale: l'intervento è quindi a un tempo meno costoso, di circa 1.304 euro, e più efficace, di circa 0,236 anni, e configura una condizione di dominanza.^[236] La dominanza non è un artificio, ma discende dalla struttura del modello: a fronte di un costo iniziale contenuto, l'intervento accresce il tempo trascorso nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce quello trascorso nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte; questo risultato per paziente è il fondamento microeconomico delle stime aggregate della Parte E ed è indipendente dalla regione.^[237] È la struttura di costo per ciclo — quaranta euro nello stato di recupero, settecento nello stato cronico, trecento una tantum per l'intervento — a generare il risultato, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso.^[238] I valori centrali e gli intervalli sono tratti

dall’evidenza internazionale e, per i parametri regionali, andranno calibrati sui valori liguri certificati e sui dati di esito che la sperimentazione, da poco avviata, produrrà.^[239] La tabella seguente riporta il risultato del caso base.

Grandezza per paziente	Usuale	Intervento	Differenza
Costo sanitario (5 anni, scontato)	~ 3.799 €	~ 2.495 €	– 1.304 €
Utilità (anni di vita ponderati)	3,392	3,627	+ 0,236
Esito complessivo	—	—	Dominanza

Tabella F.1. Il caso base per singolo paziente: l’intervento è meno costoso e più efficace (dominanza). Risultato indipendente dalla regione.

F.3 L’analisi di sensibilità

La robustezza del risultato è saggiata anzitutto con l’analisi di sensibilità a una via, nella quale ciascun parametro è fatto variare del venticinque per cento in più e in meno, misurandone l’effetto sul beneficio monetario netto; l’ordinamento dei parametri per influenza colloca tra i più rilevanti l’efficacia clinica, i tassi di ricaduta e di cronicizzazione e il costo dello stato cronico.^[240] All’incertezza dei parametri si aggiunge quella strutturale, relativa alle assunzioni del modello, trattata mediante analisi di scenario e validazione della coerenza interna ed esterna, secondo lo standard di reporting adottato.^[241] Nessuna delle variazioni considerate, prese singolarmente, modifica il segno della conclusione, a riprova della solidità del risultato di base.

F.4 L’analisi probabilistica

L’analisi di sensibilità probabilistica propaga simultaneamente l’incertezza di tutti i parametri, eseguendo il modello diecimila volte con estrazione casuale dei valori dalle rispettive distribuzioni.^[242] Adottando la soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità,^[243] la curva di accettabilità indica una probabilità dell’88,9% che l’intervento sia costo-efficace e dell’84,6% che sia addirittura dominante, con un beneficio monetario netto medio di circa 7.815 euro per paziente e un intervallo di credibilità al 95% da circa –5.736 a circa +21.501 euro.^[244] È necessaria, a questo punto, una distinzione che lo studio tiene ferma per non generare equivoci: la probabilità di costo-efficacia è un risultato di efficienza per singolo paziente, che valorizza il guadagno di salute e l’intera traiettoria di costo, ed è perfettamente coerente con il saldo diretto aggregato lievemente negativo della Parte E, poiché il passaggio dal paziente all’aggregato regionale incorpora le correzioni per peso morto e per l’effettiva monetizzabilità nel bilancio, e poiché il canale della mobilità, pur in una regione debitrice, è solo marginalmente pertinente, essendo la fuga chirurgica. L’efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è lievemente negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali.^[245]

F.5 Il valore dell’informazione e la verifica empirica

L’ultimo passaggio collega l’incertezza residua alle priorità di ricerca. Il valore dell’informazione quantifica il beneficio conseguibile riducendo l’incertezza, e indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione.^[246] In Liguria, i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso — sono quelli su cui il valore dell’informazione è più elevato, e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati alle cinque Aziende e agli IRCCS; a

differenza della Toscana, la regione non dispone ancora di propri dati di esito, che la sperimentazione appena avviata produrrà e che andranno consolidati come fonte primaria di calibrazione.^[247] La riduzione dell'incertezza non resta tuttavia un esercizio teorico, ed è qui che la Liguria gode della condizione più favorevole dell'intera serie: poiché la sperimentazione è in fase di avvio e si dispiega progressivamente tra le cinque Aziende e i loro distretti, la verifica empirica può poggiare su un disegno a cunei progressivi pianificato prospetticamente — il più pulito tra quelli realizzabili — oggetto della Parte L, che sostituisce progressivamente le stime con misure osservate sui dati liguri via via che il servizio si estende.^[248] Definiti i metodi e governata l'incertezza, lo studio può affrontare i domini successivi, a partire dall'equità e dall'impatto distributivo, oggetto della Parte G.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LIGURIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all'avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte G

Equità e impatto distributivo

L'equità come dimensione della valutazione, costo-efficacia distributiva, divari territoriali e protezione finanziaria

Ottavo dominio dell'HTA · il profilo distributivo e sociale

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte affronta l'ottavo dominio della valutazione, il profilo distributivo e sociale, e risponde al criterio di impatto della griglia di giudizio.^{[249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262]} L'equità non è trattata come un'appendice, ma come una dimensione costitutiva del valore dell'intervento, in coerenza con l'evoluzione che ha affiancato l'equità in salute agli obiettivi di esito, esperienza e costo. La parte definisce l'equità come dimensione della valutazione e ne identifica il gradiente rilevante per la Liguria (capitolo G.1); applica l'analisi costo-efficacia distributiva e ne ricava l'algoritmo allocativo (G.2); analizza i divari territoriali, la protezione finanziaria e il collegamento al monitoraggio (G.3). Il tratto distintivo ligure emerge con chiarezza: il gradiente non è prevalentemente socio-economico, ma si gioca sull'asse fra la costa e l'entroterra appenninico, sull'invecchiamento più marcato d'Italia e sulla più alta domanda nazionale di salute mentale.

G.1 L'equità come dimensione della valutazione

La salute mentale presenta un gradiente sociale documentato: le popolazioni in deprivazione hanno prevalenze più elevate di disturbi comuni e un accesso più difficile. In Liguria, tuttavia, il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato, sicché il tratto distintivo dell'equità non è il gradiente socio-economico, ma tre dimensioni diverse: la dualità fra la fascia costiera e l'entroterra appenninico, l'invecchiamento più marcato d'Italia e una dimensione multiculturale non trascurabile.^[263] Su queste dimensioni il servizio di primo livello agisce abbattendo le barriere che gravano in misura maggiore sui più svantaggiati: la gratuità rimuove la barriera economica, la prossimità e la telepsicologia quella geografica dell'entroterra, l'assenza di stigma e la competenza culturale quella linguistica e culturale per l'utenza straniera.^{[264][265]} La tabella seguente riepiloga le dimensioni dell'equità monitorate e il modo in cui l'intervento vi incide.

Barriera o dimensione	Azione dell'intervento	Gruppo più avvantaggiato
Barriera economica	Gratuità del servizio	Redditi bassi, esclusi dalla psicoterapia privata
Barriera geografica	Prossimità nelle Case della Comunità e telepsicologia	Entroterra appenninico, anziano e disperso
Barriera culturale e linguistica	Assenza di stigma; competenza culturale	Utenza straniera (~11%)
Barriera dell'attesa	Riduzione dei tempi di attesa	Chi non può ricorrere al privato
Bisogno dell'età anziana	Accesso e prossimità per gli anziani	Popolazione anziana, la più ampia d'Italia

Tabella G.1. Le dimensioni dell'«*****equità e l'*****'azione dell'intervento.

G.2 La costo-efficacia distributiva e l'algoritmo allocativo

Per misurare la dimensione distributiva lo studio impiega l'analisi costo-efficacia distributiva, che estende la valutazione economica stimando come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l'effetto sulle disuguaglianze, mediante anni di vita ponderati per l'equità, indice di concentrazione e indici di disuguaglianza.^[266] La direzione del risultato è univoca: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove l'accesso è oggi più difficile — l'entroterra, l'età anziana, l'utenza straniera, i gruppi gravati dalle liste di attesa — i benefici si concentrano sui più svantaggiati nell'accesso, sicché l'intervento migliora l'esito medio e ne comprime al tempo stesso la disuguaglianza.^[267] Attribuire pesi maggiori ai benefici sui più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, in via conservativa, il rapporto beneficio-costi non ponderato già esposto nella Parte E, dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, scelta tanto più prudente in una regione la cui popolazione non è prevalentemente deprivata.^[268] Il meccanismo operativo dell'equità è l'algoritmo allocativo: la distribuzione territoriale degli incarichi non segue la sola popolazione, ma pondera ciascun distretto per l'indice di vecchiaia, la deprivazione, la cronicità e la presenza straniera, attribuendo pesi maggiori all'entroterra appenninico e ai comuni più anziani; in Liguria l'indice di vecchiaia, il più elevato d'Italia, è il fattore di ponderazione di gran lunga prevalente.^[269] A tal fine si impiega un indice di deprivazione multipla, costruito su reddito, occupazione, istruzione, salute, condizione abitativa e ambiente, per individuare le aree prioritarie.^[270]

G.3 Divari territoriali, protezione finanziaria e monitoraggio

Il divario rilevante in Liguria non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra la fascia costiera, densa e ben servita, e l'entroterra appenninico, a popolazione anziana, dispersa e in spopolamento, dove i comuni più piccoli sono tra i più anziani d'Italia. In queste aree la sola presenza fisica di un primo livello accessibile è già un atto di riequilibrio, integrato dalla telepsicologia.^[271] Poiché il canale della mobilità recuperata è qui solo marginalmente pertinente — la fuga è chirurgica — le principali leve distributive sono la riduzione delle liste di attesa, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato, l'estensione uniforme del servizio dalla sperimentazione appena avviata a tutte le Case della Comunità delle cinque Aziende, e l'accesso nell'entroterra.^[272] A queste si aggiunge la protezione finanziaria: il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata diretta, l'impovertimento connesso alle cure e le spese catastrofiche, con beneficio maggiore per i redditi bassi.^[273] La forma più elementare di equità resta peraltro la copertura del bisogno non soddisfatto: intercettare la quota

inevasa del disagio, dell'ordine di 300.000 persone, significa raggiungere proprio chi ha minore probabilità di accedere spontaneamente, in una regione che già registra la più alta prevalenza nazionale di utenti dei servizi specialistici.^[274] Tutte queste dimensioni sono tradotte in indicatori di equità — accesso per area e per livello socio-economico, accesso dell'età anziana e dell'utenza straniera, gradiente dell'esito, tempi di attesa per area — che fanno parte del sistema di monitoraggio della Parte L e consentono di accertare nel tempo se il servizio raggiunga le comunità dell'entroterra più distanti e i gruppi più fragili.^[275] Definito il profilo distributivo, la parte che segue affronta i profili etico, giuridico e organizzativo dell'intervento.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LIGURIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all'avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Il profilo etico, il profilo giuridico e costituzionale, il profilo organizzativo e la conformità

Domini 6, 7 e 9 dell'HTA · i profili etico, organizzativo e giuridico

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte completa la valutazione affrontando tre domini del modello HTA non ancora trattati: il profilo etico, il profilo organizzativo e il profilo giuridico.^{[276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291]} La struttura è quella adottata per le altre regioni. La parte sviluppa il profilo etico, con il consenso informato e la tutela dei vulnerabili (capitolo H.1); il profilo giuridico e costituzionale, con il riparto di competenze, il precedente costituzionale e la base giuridica regionale (H.2); e il profilo organizzativo e la conformità, con la responsabilità clinica, gli strumenti di intelligenza artificiale e la protezione dei dati (H.3). Per la Liguria il profilo giuridico assume un rilievo peculiare: la regione dispone già di una legge regionale dedicata, e si tratta di darle attuazione piena entro i confini tracciati dal giudice costituzionale e nell'attesa della legge statale.

H.1 Il profilo etico

Il profilo etico muove dal principio che la persona resta il soggetto, e mai l'oggetto, della presa in carico: le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, già trattata nella Parte G, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato.^[292] Il consenso è modulare, prestato distintamente per i diversi trattamenti e reso anche in forma digitale; poiché nella salute mentale i dati sono ultrasensibili, la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi vi possa accedere.^[293] La stessa conduzione della valutazione è retta da criteri etici: gli esiti sono resi pubblici indipendentemente dal loro segno, a garanzia contro la distorsione da selezione dei risultati favorevoli, e l'intero impianto è sottoposto all'approvazione del comitato etico territorialmente competente.^[294] Particolare cura, infine, è dedicata alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante e senza che ne siano registrate le modalità.^[295]

H.2 Il profilo giuridico e costituzionale

Il fondamento costituzionale dell'intervento risiede nell'articolo 32 della Costituzione e nella legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che configurano la salute come diritto fondamentale e interesse della collettività e fondano il sistema su universalità, eguaglianza ed equità.^[296] Sul piano del riparto di competenze, la tutela

della salute è materia concorrente: allo Stato spettano i principi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio e l'organizzazione del servizio, e la Liguria ha esercitato tale competenza nella forma più piena, approvando una legge regionale dedicata e non un mero atto amministrativo.^[297] Resta ferma, peraltro, la competenza esclusiva statale sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che è la leva attraverso cui una legge statale potrebbe ricondurre la psicologia di base tra le prestazioni garantite in modo uniforme su tutto il territorio.^[298] Su questo confine si è pronunciata la Corte costituzionale: la sentenza, intervenuta su una legge regionale, ha ritenuto legittima l'organizzazione del servizio che si avvalga di professionisti già esistenti nel quadro dell'assistenza territoriale, ma ha ricondotto allo Stato la determinazione dei livelli essenziali e la disciplina dei rapporti di lavoro; la legge ligure, operando mediante un rapporto convenzionale modellato su quelli già vigenti, si colloca nello spazio legittimo, mentre il suo consolidamento pieno e l'uniformità tra le regioni restano affidati alla legge statale.^[299]

La base giuridica regionale è dunque solida e già acquisita: il servizio è istituito dall'articolo 76 della legge regionale 20 del 2023, che ne definisce gli elenchi aziendali, il rapporto convenzionale e l'Osservatorio, e in attuazione è stata avviata la sperimentazione a trentotto psicologi; la cornice di coordinamento è costituita dalla Regione, dalle cinque Aziende e dall'Azienda Ligure Sanitaria, e la decisione non verte sul prevedere la funzione né sul dotarla di una legge, già esistente, ma sul condurla a regime e dimensionarla.^[300] Il vincolo di destinazione delle risorse del Servizio sanitario alla garanzia dei livelli essenziali è rispettato, trattandosi di un servizio di primo livello a costo contenuto; la Liguria non è sottoposta a piano di rientro, ma presenta un disavanzo strutturale coperto con risorse regionali ed è debitrice nella mobilità, e l'investimento incrementale necessario, contenuto, è coerente con tale principio.^[301] Il servizio opera infine nel rispetto delle norme deontologiche, sotto la vigilanza dell'Ordine degli Psicologi della Liguria, che ha accompagnato l'iter della legge e l'avvio della sperimentazione, riunisce gli oltre tremila professionisti iscritti nella regione e concorre alla governance e alla formazione.^[302]

H.3 Il profilo organizzativo e la conformità

Sul piano organizzativo, una questione merita di essere chiarita, perché da essa dipende la sostenibilità giuridica dell'innovazione tecnologica: l'impiego dell'intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali. Il medico di medicina generale resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell'intervento psicologico, e l'intelligenza artificiale è assimilata a un dispositivo di supporto e non a una figura che compie atti, sicché non si introduce una nuova figura professionale, ma uno strumento che assiste quelle esistenti.^[303] La conformità degli strumenti è assicurata dal quadro europeo: il regolamento sull'intelligenza artificiale classifica come ad alto rischio i sistemi impiegati nei dispositivi medici, con obblighi differiti oltre il 2027; il regolamento sui dispositivi medici impone la marcatura CE; il regolamento sulla protezione dei dati ne disciplina il trattamento; vi si innestano la supervisione umana costante, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias e il divieto di discriminazione algoritmica.^[304] Per non generare nuove disuguaglianze, sono previsti canali tradizionali paralleli per chi non dispone di strumenti digitali — segnatamente le persone anziane dell'entroterra appenninico, numerose in Liguria — e il supporto multilingue per la popolazione straniera, ferma restando la garanzia dell'alternativa in presenza.^[305] La protezione dei dati, infine, è assicurata da misure robuste — crittografia e pseudonimizzazione per le analisi, consenso modulare anche digitale, collaborazione con l'Autorità garante e software dotati di marcatura adeguata.^[306] Definiti i profili etico, giuridico e organizzativo, la parte che segue affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità dell'intervento.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LIGURIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all'avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte I

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte affronta il settimo dominio della valutazione, il profilo organizzativo, e fornisce il contenuto dei casi commerciale, gestionale e finanziario del Five Case Model, rispondendo al criterio di sostenibilità.^{[307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322]} La parte espone i modelli dell'implementazione (capitolo I.1); il disegno del dimensionamento e del reclutamento (I.2); il caso commerciale, ossia l'assetto contrattuale (I.3); il caso gestionale e i rischi attuativi (I.4); e il caso finanziario, le coperture e la sostenibilità nel tempo (I.5). Il tratto specifico della Liguria attraversa l'intera parte: poiché la sperimentazione è appena avviata e di dimensione minima, l'attuazione consiste essenzialmente nel costruire il servizio a regime a partire da un avvio recente, con il vantaggio di poterne disegnare prospetticamente sia il dispiegamento sia la valutazione.

I.1 L'implementazione: i modelli RE-AIM e CFIR

L'attuazione è valutata con due strumenti consolidati. Il modello RE-AIM ne misura la riuscita e la validità esterna lungo cinque dimensioni — portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento — e per la Liguria sono dirimenti l'adozione, che muove ora i primi passi con la sperimentazione, e il mantenimento, ossia il consolidamento a regime di un servizio appena avviato.^[323] Il quadro consolidato per la ricerca sull'implementazione spiega invece i determinanti dell'attuazione lungo cinque domini — le caratteristiche dell'innovazione, il contesto esterno e interno, gli individui coinvolti e il processo — consentendo di individuare ex ante barriere e facilitatori.^[324] I determinanti seguiti dallo studio comprendono il tasso di copertura, l'adozione delle sedi, la fedeltà al modello, i tempi di dimensionamento, il numero di psicologi reclutati e formati, la qualità della formazione e della supervisione, l'integrazione nei flussi di lavoro e la scalabilità.^[325]

I.2 Il dimensionamento e il reclutamento

Il disegno del dimensionamento riflette la condizione di avvio della Liguria: poiché la sperimentazione è appena partita e dimensionata a trentotto psicologi, dell'ordine del tre-quattro per cento del fabbisogno, il dispiegamento muove essenzialmente dall'inizio e consiste nell'estensione progressiva della copertura a tutte le Case della Comunità e ai distretti delle cinque Aziende verso il regime, per fasi semestrali, a partire dalle sedi di maggiore prontezza e sotto il coordinamento dell'Azienda Ligure Sanitaria.^[326] Questo dimensionamento progressivo ha una doppia funzione, ed è qui che la Liguria gode della condizione più favorevole della serie: oltre a rispondere all'esigenza organizzativa di accrescere la copertura in modo compatibile con i tempi del reclutamento, esso, definendo prospetticamente l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi, fonda la valutazione controfattuale a cunei progressivi più pulita realizzabile, oggetto della Parte L.^[327] Il reclutamento, a fronte di un fabbisogno a regime dell'ordine di 330 psicologi, avviene tramite l'iscrizione a un elenco aziendale e l'instaurazione di un rapporto convenzionale, con requisiti di albo e di formazione; in prima applicazione la legge valorizza i professionisti con esperienza almeno biennale, e il bacino è ampio, contando la regione oltre tremila psicologi iscritti.^[328] Il cronoprogramma procede per fasi semestrali, con reclutamento, formazione e consolidamento condotti gradualmente e il monitoraggio a corredo dell'intero arco.^[329] Tra i parametri che

muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al cinquanta per cento nella fase di dimensionamento, che il monitoraggio è chiamato a verificare sui dati liguri non appena la sperimentazione inizierà a produrli.^[330] La tabella seguente riepiloga gli scenari di dimensionamento.

Fase o scenario	Psicologi	Copertura del fabbisogno
Sperimentazione attuale	~ 38 psicologi	Dell'ordine del 3-4% del fabbisogno
Scenario conservativo	~ 170 psicologi	Copertura parziale
Scenario base	~ 250 psicologi	Copertura ampia
Scenario espansivo	~ 330 psicologi	Copertura piena del fabbisogno

Tabella I.1. Gli scenari di dimensionamento, dalla sperimentazione attuale al regime.

I.3 Il caso commerciale

Il caso commerciale del Five Case Model riguarda la fattibilità dell’assetto contrattuale. Essa poggia sul rapporto convenzionale su base libero-professionale previsto dalla legge regionale, da cui discende un costo medio per incarico dell’ordine di 55.000 euro l’anno e gli scenari di spesa di 9, 14 e 18 milioni già esposti nella Parte E.^[331] Le manifestazioni di interesse per la selezione dei professionisti sono già state emanate dalle Aziende, e il nodo specifico della Liguria è la stabilizzazione progressiva del rapporto verso un assetto convenzionale a regime, analogo nella logica a quello dei medici di medicina generale, senza che ciò richieda la creazione di nuove figure professionali — punto che, come visto nella Parte H, ne sostiene anche la difendibilità costituzionale.

I.4 Il caso gestionale e i rischi attuativi

Il caso gestionale definisce il governo dell’attuazione su due livelli. A livello regionale, un comitato di indirizzo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, le cinque Aziende, l’Azienda Ligure Sanitaria, gli IRCCS San Martino e Gaslini, gli enti ospedalieri Galliera ed Evangelico, l’Ordine degli Psicologi della Liguria, la medicina generale, la pediatria di libera scelta e l’Università di Genova, affiancato dall’Osservatorio previsto dalla legge; a livello aziendale, ciascuna Azienda è responsabile dell’attuazione nel proprio ambito, e l’Azienda Ligure Sanitaria assicura il coordinamento unitario.^[332] Quanto ai rischi, il più specifico della Liguria è la fragilità di una sperimentazione appena avviata e di dimensione minima, dipendente dal finanziamento iniziale; ad esso si aggiungono il reclutamento insufficiente, la debole adesione della medicina generale e l’interoperabilità incompleta dei sistemi informativi. Poiché la legge è già vigente, la principale misura di mitigazione è la conduzione a regime con un rapporto convenzionale stabile e un dimensionamento graduale, che consente di osservare, correggere e adattare fin dalle prime fasi.^[333]

I.5 Il caso finanziario e la sostenibilità

Il caso finanziario individua le coperture: il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, dell’ordine di 3,5 miliardi di euro, di cui una quota è già destinata alla sperimentazione avviata; la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’infrastruttura territoriale e digitale; e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali.^[334] La Liguria opera sotto pressione finanziaria, con un disavanzo strutturale

coperto con risorse regionali e una mobilità passiva, pur non essendo in piano di rientro; tuttavia il costo del servizio, anche a massima copertura, è dell'ordine di mezzo punto percentuale del finanziamento, ed essendone già a bilancio una quota, l'investimento incrementale è quello necessario a colmare il divario verso il fabbisogno, sostenibile a condizione di prudenza.^[335] Sul piano della sostenibilità nel tempo, la leva decisiva per la Liguria non è l'istituzionalizzazione per legge, già acquisita, né la maturità operativa, ancora da costruire, ma la conduzione a regime con un rapporto convenzionale stabile e un dimensionamento adeguato, che sottrarrebbe il servizio alla fragilità della fase di avvio; vi concorrono la modestia del costo, il forte ritorno sociale e il coordinamento regionale dell'Azienda Ligure Sanitaria.^[336] Resta ferma la cautela metodologica che accompagna l'intero studio: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e la verifica empirica sui dati liguri, prevista dalla Parte L e fondata su un disegno a cunei progressivi pianificato fin dall'avvio, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate.^[337] Definiti l'attuazione e la sostenibilità, la parte che segue affronta il monitoraggio, la valutazione e la verifica ex post.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LIGURIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all'avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte L

Monitoraggio, valutazione e verifica ex post

Architettura della misurazione, protocollo e strumenti, baseline, valutazione controfattuale, verifica ex post

Chiusura del ciclo valutativo · monitoraggio, valutazione ed ex post

Parte L — Monitoraggio, valutazione e verifica ex post

Questa parte organizza la misurazione dell'intervento nel tempo, chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione e fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti.^{[338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356]} La struttura è quella adottata per le altre regioni. La parte definisce l'architettura della misurazione e la batteria di indicatori (capitolo L.1); il protocollo di rilevazione e gli strumenti di esito (L.2); la costituzione della baseline e il calendario (L.3); la valutazione controfattuale d'impatto (L.4); e la verifica ex post con gli indicatori compositi (L.5). Per la Liguria questa parte assume un valore particolare: poiché la sperimentazione è appena avviata, la misurazione e il disegno valutativo possono essere progettati fin dall'inizio, anziché ricostruiti a posteriori, e ciò conferisce alla regione la condizione metodologica più favorevole dell'intera serie.

L.1 L'architettura della misurazione e la batteria di indicatori

L'architettura della misurazione adotta il modello classico della qualità dell'assistenza, che distingue struttura, processo ed esito, qui integrato dalla dimensione dell'impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società.^[357] Su questa intelaiatura si innesta una batteria di circa cinquantotto misure articolate in otto categorie: una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti, mentre la quota che in altre regioni proviene da una sperimentazione già matura va in Liguria interamente rilevata, e proprio questa circostanza consente di progettare la rilevazione fin dall'inizio in forma completa e uniforme.^[358] La selezione degli esiti segue i criteri internazionali del consenso strutturato, che individuano un nucleo parsimonioso di misure essenziali evitando la proliferazione di indicatori ridondanti.^[359] La tabella seguente espone le otto categorie e lo stato della baseline.^[360]

Categoria	Contenuto	Stato della baseline
1. Bisogno e domanda	Prevalenza, accessi, domanda intercettata	Disponibile
2. Accesso ed equità	Accesso per area, età, condizione; costa-entroterra	Da rilevare
3. Processo	Prese in carico, attesa, sedute, invii	Da rilevare
4. Esito clinico	Recupero, miglioramento affidabile (PHQ-9, GAD-7)	Da rilevare
5. Economici	Risparmi per canale, costi	Misto
6. Impatto sociale	Produttività, invalidità, sollievo familiare	Misto
7. Organizzativi	Copertura, adozione, fedeltà al modello	Da rilevare
8. Variabili di sintesi	Indicatori compositi	Da calcolare

Tabella L.1. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline; la quota da rilevare è ampia, ma progettabile fin dall'avvio.

L.2 Il protocollo di rilevazione e gli strumenti di esito

Il protocollo minimo di rilevazione è attivo dal primo giorno e registra la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni; è deliberatamente essenziale per non gravare sull'attività clinica, e in Liguria, poiché la sperimentazione è appena avviata, può essere disegnato fin dall'inizio in forma completa e uniforme, anziché strutturare a posteriori una rilevazione già in corso.^[361] Gli strumenti di esito sono i questionari validati e di uso internazionale già richiamati — il PHQ-9, con punteggio da 0 a 27, soglia di rilevanza clinica intorno a 10 e cambiamento affidabile dell'ordine di 6 punti, e il GAD-7 per l'ansia — impiegati nei soli punteggi complessivi.^[362] La raccolta delle misure a ogni seduta, secondo il modello inglese, consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non protrarre percorsi inefficaci.^[363]

L.3 La costituzione della baseline e il calendario

La baseline si costituisce su due binari. Gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti — demografici, epidemiologici, di benessere, di mortalità — forniscono la fotografia del prima; e poiché in Liguria il servizio si dispiega essenzialmente dall'inizio, il periodo anteriore all'attivazione costituisce per tutte le cinque Aziende una base di confronto particolarmente pulita, completata dalla rilevazione strutturata di servizio.^[364] Il calendario prevede la costituzione della baseline con i dati disponibili e con il periodo pre-attivazione, la registrazione corrente, la trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale e all'Osservatorio con cadenza mensile, e il calcolo periodico delle misure di sintesi con aggiornamento del cruscotto regionale.^[365]

L.4 La valutazione controfattuale d'impatto

Il cuore metodologico della parte è la valutazione controfattuale d'impatto, che misura l'effetto causale dell'intervento confrontando gli esiti dei trattati con ciò che sarebbe accaduto in loro assenza. È qui che la Liguria gode della condizione più favorevole dell'intera serie: poiché la sperimentazione è appena avviata e si dispiega progressivamente tra le cinque Aziende e i loro distretti, lo strumento è un vero disegno a cunei progressivi pianificato prospetticamente, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi sono stabiliti in anticipo a fini valutativi, e non ricostruiti a posteriori.^[366] L'analisi impiega la differenza-nelle-differenze, che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le sedi attivate prima e quelle attivate dopo, sotto l'ipotesi di andamento parallelo, affiancata dal controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata delle sedi non ancora attivate.^[367] L'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e quello sui soli trattati; i disegni a cunei progressivi sono lo strumento raccomandato dalla letteratura per gli interventi di salute della popolazione, e la loro pianificazione prospettica ne accresce la validità interna.^[368] Concretamente, confrontando l'andamento degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche — particolarmente elevati in Liguria — nelle sedi attivate per prime con quello delle sedi attivate più tardi, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata sui dati liguri.^[369]

L.5 La verifica ex post e gli indicatori compositi

Il ciclo valutativo si chiude con la verifica ex post. Sul piano nazionale, la verifica dell'impatto della regolamentazione è una valutazione ex post, di norma dopo un biennio, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma.^[370] Sul piano regionale, la clausola valutativa impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale; in Liguria, dove il servizio è già istituito dalla legge regionale 20 del 2023 e dove la legge stessa prevede un Osservatorio, tale clausola si innesta su una base legislativa già esistente e lega la misurazione tecnica alla responsabilità politica e alla trasparenza verso il legislatore.^[371] Le misure di sintesi sono costruite secondo il manuale internazionale per gli indicatori compositi, che ne articola in dieci passi la costruzione e la validazione,^[372] sull'esempio istituzionale degli indicatori di benessere equo e sostenibile entrati nel ciclo della programmazione economica.^[373] A garanzia della coerenza, il divieto di doppia contabilizzazione impone che ogni grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali adottata nella Parte E.^[374] Definito il sistema di monitoraggio e valutazione, la parte conclusiva ricomponе l'intera analisi e formula le raccomandazioni operative.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LIGURIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all'avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Ricomposizione secondo i criteri OCSE-DAC, analisi multi-criterio, cruscotto decisionale, raccomandazioni e limiti

Sintesi conclusiva · la griglia di giudizio e il caso strategico

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclusiva ricompone l’intera analisi applicando la griglia di giudizio del telaio — i criteri dell’OCSE-DAC — e fornisce il contenuto del caso strategico del Five Case Model.^{[375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390]} La parte ricompone l’intervento secondo i sei criteri dell’OCSE-DAC (capitolo M.1); ne formalizza il bilanciamento con l’analisi multi-criterio (M.2); ne sintetizza il risultato nel cruscotto decisionale e nella raccomandazione centrale (M.3); e ne dichiara i limiti, le cautele e l’agenda di ricerca (M.4). Nel chiudere lo studio della Liguria, la parte ne ribadisce il tratto specifico, che la distingue dalle sei regioni già esaminate: un servizio già istituito da una legge regionale dedicata, la cui sperimentazione è però appena avviata e va condotta a regime e dimensionata.

M.1 La ricomposizione secondo i criteri OCSE-DAC

I criteri internazionali di valutazione, riveduti nel 2019, offrono sei lenti complementari per un giudizio complessivo: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità.^[391] Applicate alla Liguria, esse convergono in un giudizio coerente. L’intervento è rilevante, poiché risponde a un bisogno reale e ampio — dell’ordine di 300.000 persone con disagio comune in larga parte inevaso, nella regione con la più alta prevalenza nazionale di utenti dei servizi di salute mentale.^[392] È coerente con gli standard dell’assistenza territoriale, con la Missione 6 del PNRR e con la legge regionale che già ne ha istituito la funzione, ed è costituzionalmente difendibile entro i confini tracciati dal giudice delle leggi.^[393] È efficace secondo l’evidenza internazionale, con la riserva, dichiarata, che la Liguria non dispone ancora di dati di esito propri e poggia perciò sui benchmark e sul disegno prospettico.^[394] È efficiente in termini di costo-utilità, con dominanza per paziente, a fronte di un saldo diretto lievemente negativo di entità modesta rispetto al finanziamento regionale.^[395] Ha un impatto distributivo favorevole, concentrando i benefici dove l’accesso è più difficile e riducendo il gradiente territoriale, con un ritorno complessivo di 3,8-5,5 a uno.^[396] È, infine, sostenibile, con la precisazione che la leva decisiva non è la legge, già vigente, né la maturità operativa, ancora da costruire, ma la conduzione a regime con un rapporto convenzionale stabile.^[397] La tabella seguente sintetizza il giudizio per criterio.

Criterio	Giudizio	Motivazione sintetica per la Liguria
Rilevanza	Alta	Bisogno ampio (~300.000); più alta domanda nazionale; obbligo dei livelli essenziali
Coerenza	Alta	Coerente con DM 77, PNRR e L.R. 20/2023; difendibile entro i confini costituzionali
Efficacia	Da confermare sui dati locali	Evidenza internazionale solida (recupero ~50%); dati propri non ancora disponibili
Efficienza	Elevata (allocativa)	Dominanza per paziente; saldo diretto lievemente negativo
Impatto	Favorevole	Benefici sui più svantaggiati nell’accesso; ritorno 3,8-5,5 a uno
Sostenibilità	Buona, condizionata	Costo modesto; leva = strutturazione a regime e rapporto convenzionale stabile

Tabella M.1. La ricomposizione dell’intervento secondo i sei criteri di valutazione OCSE-DAC.

M.2 L'analisi multi-criterio

Per rendere esplicito il bilanciamento dei criteri non riducibili a denaro — l'equità, la fattibilità, la coerenza strategica, la robustezza dell'evidenza — lo studio impiega l'analisi multi-criterio, che attribuisce a ciascun criterio un peso e a ciascuna opzione un punteggio.^[398] Su otto criteri pesati, l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 80,80 su 100 contro 39,25 dell'opzione di non intervento, e prevale su tutti i criteri tranne la fattibilità immediata. Rispetto alla Toscana, il risultato ligure presenta una differenza istruttiva: il sub-punteggio di fattibilità resta elevato, poiché la regione dispone già di una legge dedicata e di una sperimentazione avviata, mentre il sub-punteggio di robustezza dell'evidenza propria è più contenuto, non disponendo la Liguria di dati di esito già maturi; il risultato resta comunque stabile rispetto ai pesi adottati.^[399] La tabella seguente riporta i criteri, i pesi e i punteggi delle due opzioni.

Criterio	Peso	Intervento	Opzione zero
Efficacia clinica	15%	80	30
Costo-efficacia e ritorno	20%	85	25
Impatto sul bilancio e sostenibilità	15%	70	50
Equità	15%	88	30
Valore sociale	10%	90	25
Fattibilità	10%	85	80
Robustezza dell'evidenza	10%	62	55
Coerenza strategica	5%	88	35
Punteggio complessivo	100%	80,80	39,25

Tabella M.2. L'*****analisi multi-criterio: punteggi delle due opzioni; la robustezza dell'*****evidenza propria è il criterio su cui la Liguria è oggi più esposta.

M.3 Il cruscotto decisionale e la raccomandazione

La sintesi per il decisore si lascia condensare in tre affermazioni. Il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, trascurabile rispetto a un finanziamento dell'ordine di 3,5 miliardi, pur con una salienza diretta non nulla nel contesto delle liste di attesa e della più alta domanda nazionale di salute mentale; il ritorno per la collettività è ampio, dell'ordine di 3,8-5,5 a uno; e il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali.^[400] Da qui la raccomandazione centrale, che per la Liguria è netta: la decisione rilevante non è se introdurre la funzione, già istituita dalla legge regionale e avviata in via sperimentale, né se dotarla di una legge, già esistente, ma se condurla dall'avvio della sperimentazione alla strutturazione a regime, stabilizzando il rapporto convenzionale previsto dalla legge, e dimensionarla, portandola dalla copertura attuale, dell'ordine del tre-quattro per cento del fabbisogno, alla copertura

sistematica, dell'ordine di 250 incarichi nello scenario di base e di 330 in quello espansivo.^[401] Letta lungo le cinque dimensioni dell'esito di salute, dell'esperienza, del costo, del benessere degli operatori e dell'equità, la sintesi del valore conferma un beneficio multidimensionale e non riducibile al solo saldo di bilancio.^[402]

M.4 I limiti, le cautele e l'agenda di ricerca

La credibilità dello studio richiede di dichiararne i limiti senza attenuazioni. Il limite principale attiene al radicamento nei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione ligure, e non estratte dai conti regionali certificati delle cinque Aziende e degli IRCCS; tale sostituzione è la condizione per la presentazione agli organi di controllo, ed è in Liguria, a differenza della Toscana, ancora poco mitigata da dati operativi, poiché la sperimentazione è appena avviata.^[403] A ciò si aggiungono le cautele di trasferibilità e di fonte già richiamate, e il fatto che la cifra del ritorno è prudenziale e non ponderata per l'equità.^[404] Ne discende l'agenda di ricerca: l'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati, seguito dalla strutturazione della rilevazione di servizio fin dall'avvio e dalla valutazione controfattuale fondata su un disegno a cunei progressivi pianificato prospetticamente, che la condizione di avvio della Liguria rende, come si è visto, particolarmente solido.^[405]

Con questa parte si chiude lo studio regionale della Liguria, settimo della serie costruita con il telaio integrato dopo quelli della Puglia, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, del Piemonte e della Toscana. Ne emerge un profilo specifico e distinto da tutti i precedenti: la Liguria è la regione più anziana d'Italia, con la più alta domanda nazionale di salute mentale, e dispone già di una legge regionale dedicata, ma la sua sperimentazione è appena avviata. Per essa la posta non è introdurre il servizio né dotarlo di una base giuridica, già acquisita, ma condurlo dalla fase di avvio alla strutturazione a regime, stabilizzando il rapporto convenzionale e dimensionando l'offerta; e proprio questa condizione di avvio offre alla regione l'occasione metodologica più favorevole della serie, quella di disegnare fin dall'inizio una valutazione controfattuale a cunei progressivi capace di trasformare le stime in prove. Resta ferma la distinzione che attraversa l'intero studio: un caso finanziario diretto lievemente negativo, in una regione debitrice la cui fuga è però chirurgica e non psicologica, e un caso economico per la collettività ampiamente positivo, fondato sulle ricadute sociali, con un rapporto beneficio-costi prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LIGURIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge all'avvio della sperimentazione al servizio strutturato a regime

Appendici A-E

Corredo tecnico e documentale

Caso di riferimento, strumenti di esito, dati regionali, standard di reporting, glossario

Materiali a sostegno delle Parti da A a M

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l'orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità.^{[406][407][408][409][410][411][412][413][414]} La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Servizio attuale (sperimentazione appena avviata) o assenza del servizio a regime
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Azienda/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudentiale	Riduzione per l'ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura.^[415] La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato della Liguria, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.^[416] La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 170	~ 250	~ 330
Costo del servizio	~ 9	~ 14	~ 18
Risparmi diretti (SSR)	~ 6	~ 10	~ 14
Ricadute economico-sociali	~ 29	~ 55	~ 85
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -3	~ -4	~ -4
Saldo complessivo (caso economico)	+26	+51	+81
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,6:1	~5,5:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell'esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario.^[417] La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura.^[418] La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori liguri impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.^[419]

Ambito	Valore regionale
Popolazione regionale	1.510.143 abitanti (Censimento ISTAT 2024); in lievissimo aumento solo per saldo migratorio; la struttura per età più anziana d'Italia (indice di vecchiaia ~277; over-65 ~29%); stranieri ~10,8%
Finanziamento del SSR	Dell'ordine di 3,5 miliardi di euro; sotto pressione finanziaria; disavanzo strutturale coperto con risorse regionali; nessun piano di rientro in atto
Mobilità sanitaria	Saldo passivo (~ -70 milioni) e in peggioramento; regione debitrice; fuga concentrata nelle specialità chirurgiche; canale di recupero marginale per questo intervento
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche dell'ordine di ventimila l'anno, sopra la media nazionale
Farmaceutica	Consumo regionale delle categorie dei psicofarmaci
Salute mentale	~ 300.000 con disagio comune; ~ 58.000 in carico ai servizi (la più alta prevalenza d'Italia)
Funzione attuale	Servizio di psicologia territoriale istituito dall'articolo 76 della legge regionale 20/2023; sperimentazione appena avviata (entro fine 2025), dimensionata a trentotto psicologi su base libero-professionale, nelle Case della Comunità Hub; legge dedicata già vigente; ~ 3-4% del fabbisogno

Tabella C.1. I valori regionali di ancoraggio della Liguria.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione ligure, e non estratti dai conti regionali certificati.^[420] La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Dati della sperimentazione	Prese in carico, sedute ed esiti che la sperimentazione appena avviata inizierà a produrre, da consolidare come fonte primaria
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Azienda e per area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[421] La tabella seguente li riepiloga.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.^[422] Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra gruppi a diversa esposizione
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità a minore esposizione
Disegno a cunei progressivi prospettico	Disegno controfattuale impiegato in Liguria, ove la sperimentazione è appena avviata, fondato su un'attivazione scaglionata tra le cinque Aziende e i loro distretti pianificata in anticipo a fini valutativi

Termine	Definizione
Analisi e verifica d'impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta a riferire al Consiglio sui risultati della riforma
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell'implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall'impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d'ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l'intensità dell'intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; in Liguria il saldo è passivo (regione debitrice), ma la fuga è chirurgica, sicché il canale del recupero è marginale per questo intervento
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di vecchiaia	Rapporto tra ultrasessantacinquenni e giovani sotto i quindici anni; in Liguria il più elevato d'Italia
Peso morto	Quota dell'esito che si sarebbe verificata anche senza l'intervento

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

68

68

Lombardia — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Lombardia

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione Lombardia sulla riforma «Psicologo di Base», nella cornice della legge regionale n. 22 del 2021. Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell'intero corpus: la premessa, l'indice generale di tutte le parti e appendici, la mappa di integrazione del telaio e la sintesi del valore. La sua funzione è di rendere i numerosi documenti dello studio un insieme coerente e leggibile come un'unica opera.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa una metodologia riconosciuta; le appendici ne raccolgono il materiale di riferimento. L'intero studio è fondato su una distinzione cardine, mantenuta in ogni parte: quella tra i risparmi diretti per il bilancio sanitario e le ricadute economico-sociali per la collettività. Da essa discende la tesi centrale dello studio lombardo, articolata in tre affermazioni congiunte e dichiarate senza attenuazioni: il servizio costa al bilancio una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, trascurabile rispetto a un finanziamento di ventuno miliardi; restituisce alla collettività un valore dell'ordine di quattro euro per ogni euro speso; e adempie all'obbligo di garantire i livelli essenziali. Rispetto alla Puglia, regione debitrice di mobilità e in disavanzo, la Lombardia presenta un caso diretto più debole — per l'assenza del canale della mobilità e per un sistema già efficiente — e un valore che poggia, in misura ancora maggiore, sulle ricadute sociali.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell'intero corpus, che può essere percorso nell'ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.3	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, costo-efficacia distributiva, divari e impoverimento
Parte H	H.1-H.3	Profili etico, giuridico e organizzativo: etico, costituzionale, organizzativo e conformità
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: implementazione, dispiegamento, casi commerciale e gestionale, sostenibilità
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio, valutazione ed ex post: indicatori, protocollo, controfattuale, verifica ex post, cruscotto
Parte M	M.1-M.4	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: griglia OCSE-DAC, analisi multi-criterio, raccomandazioni, limiti
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati regionali e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio come griglia di giudizio, convergendo nella sintesi. La tabella seguente riporta, per ciascuna parte, il dominio HTA, il caso del Five Case Model e il criterio OCSE-DAC corrispondenti.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — negativo per la Lombardia — e il saldo complessivo, nettamente positivo.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 60	~ 95	~ 120
Risparmi diretti (SSR)	~ 35	~ 60	~ 90
Ricadute economico-sociali	~ 190	~ 360	~ 560
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -25	~ -35	~ -30
Saldo complessivo (caso economico)	+165	+325	+530
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,8:1	~4,4:1	~5,4:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante non è se prevedere il servizio — già previsto dalla legge regionale n. 22 del 2021, che ne ha tracciato la collocazione nelle Case della Comunità — ma se strutturarne e dimensionarlo, portandolo dalla previsione verso i circa 2.190 psicologi a regime, il fabbisogno più elevato d'Italia. Il limite principale, dichiarato con franchezza, è che le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali, scalati per la quota di popolazione regionale del 17,0%, anziché estratte dai conti regionali certificati: è la lacuna prioritaria da colmare, presso le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, prima della presentazione esterna.

Lo studio si fonda, sul piano comparativo, sui programmi internazionali più autorevoli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie — il programma inglese di terapie psicologiche, il modello olandese, l'iniziativa australiana e il Collaborative Care statunitense — dei quali mutua le evidenze con le dovute cautele di trasferibilità. L'intera architettura, infine, è trasferibile: il telaio e il caso di riferimento sono fissi e comuni a tutte le regioni, e ciascuna regione fornisce i propri dati certificati, sicché lo studio lombardo costituisce al tempo stesso un documento compiuto per la Lombardia e un'applicazione del modello di riferimento già elaborato per la Puglia. Con questo documento di apertura, il corpus dello studio integrale per la Lombardia — undici parti e cinque appendici — è ordinato e navigabile come un'unica opera.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance dei dati ed etica

Primo volume dello studio integrale per la Lombardia · estensione del modello validato sulla Puglia

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per la Lombardia, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati alla Lombardia. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo

A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). È la parte che rende lo studio insieme rigoroso, riproducibile e confrontabile con quello pugliese e con quelli delle altre Regioni.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Servizio di Psicologia di Base nelle cure primarie della Lombardia, inteso come realizzazione strutturata e quantificata della funzione psicologica territoriale già prevista, in forma generica, dalla riforma del sistema sociosanitario disposta con la legge regionale n. 22 del 2021, e ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sul portare il servizio a regime.^[423] La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante non è se prevedere la funzione — già prevista dalla riforma del 2021, che colloca esplicitamente lo psicologo nelle Case della Comunità — ma se strutturarla e dimensionarla: la funzione è oggi tracciata ma non ancora dotata di un modello operativo, di un dimensionamento e di una copertura, a fronte di un fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 2.190 psicologi, il più elevato fra le regioni italiane. Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di due milioni di persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale dell'ordine di 150.000 persone, in un quadro segnato dall'ampia domanda metropolitana, dal lascito della pandemia che ha colpito la regione con eccezionale violenza e da una componente di cronicità e di disagio dell'età anziana accentuata nelle aree alpine. La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici: è ciò che il quesito di valutazione, formulato qui di seguito, mette a fuoco.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti lombardi con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è lo psicologo di base nelle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, portato a regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale la funzione è prevista ma non strutturata né dimensionata. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario della Lombardia, con le sue otto Agenzie di Tutela della Salute, le ventisette Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e la rete delle Case della Comunità in costruzione. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per la Lombardia
Popolazione	Residenti lombardi con disagio psichico comune (~2.000.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Psicologo di base nelle cure primarie, primo livello e filtro, portato a regime (~1.100/1.700/2.190 incarichi)
Confronto	Condizione attuale: funzione prevista dalla riforma del 2021 ma non strutturata né dimensionata
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale della Lombardia; otto ATS, ventisette ASST, circa cento distretti, Case della Comunità

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell'HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell'OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l'intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e il servizio attuale come comparatore. Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Agenzie di Tutela della Salute, le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale, ovvero funzione non strutturata a regime
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per ATS, ASST e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. A presidio dell'attendibilità, il modello incorpora una correzione prudenziale per la tendenza, documentata nella letteratura sulla valutazione degli investimenti pubblici, a sottostimare i costi e a sovrastimare i benefici, adottando per le conclusioni il valore centrale o l'estremo conservativo dell'intervallo. Tale prudenza assume, per la Lombardia, un rilievo particolare: poiché la regione è a saldo di mobilità attivo, il canale del recupero della mobilità passiva non si applica, e il caso economico poggia in misura ancora maggiore sulle ricadute sociali, che lo studio stima con criteri conservativi.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post. Decisivo anche per la Lombardia è il disegno controfattuale: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Agenzie di Tutela della Salute, attivate in tempi diversi, funge da esperimento naturale e consente di stimare l'effetto causale con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria
Ritorno sociale	Parte E	Valore sociale monetizzato
Modellazione e incertezza	Parte F	Proiezione e governo dell'incertezza
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Equità e impatto distributivo
Inferenza causale	Parte L	Effetto reale dell'intervento
Revisione sistematica e GRADE	Parte D	Sintesi e certezza dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Sintesi dei criteri non monetari
Impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post
Tutele e protezione dei dati	Parte H	Garanzie etiche e giuridiche

Tabella A.3. Le dieci metodologie e la loro collocazione nello studio.

Va infine dichiarato, già in apertura, il limite di fonte che attraversa l'intero studio. I valori economici qui impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione, pari per la Lombardia al 17,0%, e non estratti dai conti regionali certificati; una specifica di estrazione, da indirizzare alle Agenzie di Tutela della Salute e alle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, individua i dati da acquisire a sostituzione dei parametri stimati. Su questa base, lo studio adotta come riferimento la tabella unica consolidata, che distingue il risparmio diretto per il bilancio dalle ricadute economico-sociali. Per la Lombardia tale distinzione conduce a un esito onesto e specifico: il saldo diretto è negativo, dell'ordine di alcune decine di milioni per scenario, perché il canale della mobilità non si applica e il sistema è già efficiente, mentre il ritorno complessivo, dell'ordine di 3,8-5,4 a 1, proviene quasi interamente dalle ricadute sociali.

A.3 La governance dei dati, l'etica e le tutele

L'ultimo capitolo di questa parte fissa le garanzie sotto le quali l'analisi e, soprattutto, l'eventuale attuazione e valutazione del servizio procedono. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo, che riunisce la Regione e le Agenzie di Tutela della Salute, le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, le università e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ed è affidata a un responsabile scientifico; è sottoposta all'approvazione del comitato etico territorialmente competente; prevede il consenso informato dei partecipanti; e rende pubblici gli esiti indipendentemente dal loro segno, a garanzia di non distorsione. Questo assetto di governo non è una formalità, ma la condizione perché i risultati siano credibili e perché la sperimentazione, ove avviata, produca conoscenza utilizzabile e non un mero esercizio di conferma.

La protezione dei dati personali è trattata con il rigore che la natura ultrasensibile dei dati psicologici impone. Il trattamento è conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e misure di sicurezza; i dati individuali restano nel servizio per la sola finalità clinica, e al livello di governo regionale sono trasmessi

esclusivamente indicatori aggregati e anonimi, non riconducibili alla persona. Il sistema informativo è concepito come interoperabile con il Fascicolo Sanitario Elettronico, su infrastruttura regionale sicura e con consenso modulare, in modo che la persona possa governare l'uso dei propri dati per finalità diverse da quella clinica.

L'impiego dell'intelligenza artificiale, che attraversa il modello organizzativo trattato nelle parti successive, è qui ricondotto a un principio cardine: gli strumenti operano come ausilio del clinico, alla stregua di un copilota, e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante, validazione periodica degli algoritmi e monitoraggio dei bias, in conformità al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e alla disciplina sui dispositivi medici. Tale impiego, in Lombardia, si innesta coerentemente sulla previsione regionale di strumenti di intelligenza artificiale nelle Centrali Operative Territoriali, e si accompagna all'auspicio di un comitato etico-scientifico dedicato. A presidio delle persone più fragili, infine, gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante, senza che lo studio registri o tratti il dettaglio delle modalità, a garanzia di sicurezza e di dignità della persona.

Con la definizione dello scopo e del quesito, del caso di riferimento e dei metodi, e delle garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati, questa prima parte fonda l'impianto dello studio. Le parti che seguono ne svolgono i domini, a partire dal problema di salute, dal bisogno e dal contesto della Lombardia, oggetto della Parte B.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Profilo demografico, epidemiologia del bisogno, domanda e offerta, disuguaglianze, servizi e flussi, cornice normativa

Dominio 1 del modello HTA · caso strategico · criteri di rilevanza e coerenza

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Questa parte corrisponde, nel telaio integrato, al primo dominio della valutazione di tecnologia sanitaria — il problema di salute e l'uso corrente — e fonda il caso strategico della decisione, rispondendo ai criteri di rilevanza e di coerenza. Essa stabilisce l'entità e la natura del bisogno cui la riforma intende rispondere, l'adequazione dell'offerta attuale, i divari territoriali, la pressione sui servizi e la cornice normativa entro cui l'intervento si colloca. È la base fattuale su cui poggiano le parti successive: senza una misura rigorosa del problema, la valutazione dell'intervento resterebbe priva di termine di confronto. Il quadro lombardo, come si vedrà, differisce per più tratti da quello pugliese, e tali differenze sono dichiarate con franchezza, perché da esse dipende la fisionomia del caso economico.

B.1 Profilo demografico e socioeconomico

La Lombardia conta una popolazione di poco superiore ai dieci milioni di abitanti — 10.033.918 al Censimento permanente del 2024, pari al 17,0% del totale nazionale, la più popolosa d'Italia — distribuita in dodici province e organizzata, sul piano sanitario, in otto Agenzie di Tutela della Salute, ventisette Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e, per effetto della riforma del 2021, circa cento distretti. Il profilo demografico è composito: la componente straniera, pari al 12,2% dei residenti e nettamente superiore alla media nazionale, alimenta la crescita; l'aspettativa di vita, dell'ordine di ottantaquattro anni, è tra le più elevate del Paese; e la

Città Metropolitana di Milano, con un capoluogo che da solo supera 1,36 milioni di residenti, domina il quadro insediativo, accanto alle popolose province di Brescia, Bergamo e Monza-Brianza e alle aree alpine di Sondrio e delle valli.

La composizione orienta un fabbisogno articolato e, per dimensione e varietà, senza pari nel Paese. L’area metropolitana milanese presenta un’ampia popolazione in età lavorativa, relativamente più giovane, con elevata domanda di salute mentale connessa ai disturbi comuni e ai ritmi di vita urbani; le province di Bergamo e Brescia, fra le più giovani della regione, condividono un tessuto produttivo dinamico; mentre l’invecchiamento, comune a tutte le regioni avanzate, e le aree alpine a popolazione anziana e dispersa aggiungono una componente di cronicità e di difficoltà di accesso. La Lombardia, per dimensioni e composizione, riassume in sé tutte le tipologie di fabbisogno — metropolitano, produttivo, anziano, montano — il che fa del servizio uno strumento di particolare versatilità.

Sul piano socioeconomico, il caso lombardo si distingue nettamente da quello meridionale. La regione è il principale motore economico del Paese, e il rischio di povertà o esclusione sociale vi è tra i più contenuti d’Italia, dell’ordine del 18%, nettamente inferiore alla media nazionale; la deprivazione, pur ridotta in aggregato, si concentra in alcune aree alpine interne e in talune periferie urbane. Ne discende una conseguenza importante per l’analisi: mentre nelle regioni meridionali il disagio psichico è trainato in misura preponderante dalla deprivazione, in Lombardia il bisogno è sospinto soprattutto dall’intensità della vita metropolitana, dal lascito della pandemia e dall’invecchiamento delle aree montane. La tabella seguente sintetizza i tratti demografici e socioeconomici essenziali.

Indicatore	Valore per la Lombardia
Popolazione (Censimento 2024)	10.033.918 (~17,0% del totale nazionale)
Aspettativa di vita	~ 84 anni, tra le più elevate d’Italia
Componente straniera	12,2% dei residenti, motore della crescita
Articolazione del territorio	Dodici province; Città Metropolitana di Milano (>1,36 mln)
Profilo per età	Composito: metropolitano e produttivo (Milano, Bergamo, Brescia), anziano e montano (Sondrio, valli)
Rischio di povertà o esclusione	~ 18%, tra i più contenuti d’Italia
Articolazione sanitaria	Otto ATS, ventisette ASST, ~100 distretti

Tabella B.1. Profilo demografico e socioeconomico della Lombardia.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale in Lombardia si articola, come altrove, su due piani: il sommerso, ampio e in larga parte non intercettato, e l’emergente, che preme sui servizi specialistici e di emergenza. Sul primo piano, si stima che circa due milioni di persone presentino disagio psichico comune o sottosoglia, dell’ordine del 20-30% della popolazione adulta; su questa massa di bisogno la risposta territoriale strutturata è oggi assente. A tale quadro la Lombardia aggiunge un tratto specifico: il lascito psicologico della pandemia, di cui la regione fu

l’epicentro nazionale, con eccezionale violenza nelle province di Bergamo e Brescia. La letteratura documenta un impatto duraturo sulla popolazione generale e, in misura accentuata, sugli operatori sanitari, che concorre alla domanda attuale.

A differenza di alcune regioni meridionali, in Lombardia la rilevazione del sommerso non sconta una marcata sotto-dichiarazione. La sorveglianza PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità colloca la quota di adulti con sintomi depressivi clinicamente rilevanti in prossimità della media nazionale, dell’ordine del 6-7%: la domanda è dunque più visibile, e si traduce in pressione sui servizi e, soprattutto, sulle liste di attesa. Il divario tra prevalenza reale e accesso ai servizi — il treatment gap — resta nondimeno strutturale, riconosciuto anche dalla Commissione europea, che nel 2024 ha rilevato come solo la metà delle persone con ansia o depressione chieda aiuto e come quasi un giovane su due resti privo di supporto adeguato. È precisamente questo divario che un servizio di primo livello, accessibile e privo di stigma, ha la funzione di colmare.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

A fronte di un bisogno di dimensione assoluta senza pari, l’offerta psicologica pubblica è storicamente esigua. Secondo i dati del Ministero della Salute riferiti al 2017, l’Italia dispone di 8,5 psicologi ogni centomila abitanti nel Servizio sanitario complessivo, e di meno di tre ogni centomila nelle sole strutture pubbliche di salute mentale, una delle dotazioni più basse d’Europa. La domanda che non trova risposta nel territorio si riversa sui servizi specialistici e di emergenza. I Dipartimenti di Salute Mentale lombardi hanno in carico un’utenza stimabile, per quota di popolazione, nell’ordine di 150.000 persone, e gli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche sono dell’ordine di quarantacinque-cinquantamila l’anno, con le sindromi nevrotiche e somatoformi quale causa più frequente: quadri comuni che non richiederebbero il contesto dell’emergenza, e che vi approdano in assenza di un primo livello territoriale.

Il divario tra bisogno e offerta definisce la posta in gioco della decisione, che in Lombardia ha natura diversa che in Puglia: non si tratta di portare a regime un servizio già istituito e dotato, ma di strutturare e dimensionare una funzione che la riforma del 2021 ha previsto senza ancora attuarla. Il fabbisogno a regime, applicando i rapporti organizzativi del modello, è dell’ordine di 2.190 psicologi, il più elevato d’Italia, a fronte di una copertura strutturata oggi sostanzialmente nulla. Lo studio considera tre scenari di copertura — circa 1.100, 1.700 e 2.190 incarichi — che conducono il servizio progressivamente verso la copertura del bisogno. La tabella seguente riepiloga le grandezze della domanda, dell’offerta e del divario.

Grandezza	Valore per la Lombardia
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 2.000.000 di persone
Utenza stimata in carico ai Dipartimenti	~ 150.000
Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche	~ 45.000-50.000 l’anno
Offerta territoriale strutturata attuale	Funzione prevista (L.R. 22/2021) ma non strutturata
Fabbisogno stimato a regime	~ 2.190 psicologi (il più elevato d’Italia)
Copertura attuale del fabbisogno	~ 0% (servizio non ancora dimensionato)

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

Il bisogno e l'offerta non si distribuiscono uniformemente sul territorio regionale, e l'equità interna è perciò una dimensione costitutiva della valutazione. In Lombardia i divari assumono una fisionomia particolare: non il gradiente meridionale della deprivazione diffusa, ma il contrasto tra un'area metropolitana densa e ben servita e le aree alpine interne, a popolazione anziana e dispersa, dove l'accesso ai servizi è strutturalmente più difficile, accanto a talune periferie urbane fragili. Sono le aree in cui i determinanti del disagio si addensano e in cui, al tempo stesso, la rete è più rada.

Il disegno del servizio riconosce questi divari e li affronta in sede di distribuzione territoriale degli incarichi. L'algoritmo allocativo non ripartisce le risorse in proporzione alla sola popolazione, ma pondera ciascun distretto per l'indice di vecchiaia, per l'indice di deprivazione socioeconomica e per la prevalenza di cronicità e multimorbidità, attribuendo pesi maggiori alle aree alpine interne e alle periferie più fragili. In Lombardia, dove le liste di attesa sono il principale segno di disuguaglianza nell'accesso, la loro misura per area è tra le variabili che lo studio segue come prioritarie, in quanto consente di verificare se il servizio raggiunga effettivamente le comunità più distanti, e non solo quelle già meglio servite.

B.5 I servizi e i flussi

Il contesto di bilancio lombardo si distingue nettamente da quello pugliese. La Lombardia dispone del più ampio finanziamento sanitario regionale del Paese, dell'ordine di ventuno miliardi di euro, e presenta conti in sostanziale equilibrio; a differenza della Puglia, non è sottoposta a piano di rientro. Permane nondimeno il vincolo generale di destinazione delle risorse ai livelli essenziali, e con esso l'esigenza, comune a ogni amministrazione, di dimostrare l'efficienza e il ritorno di ciascuna nuova linea di spesa.

Il tratto più distintivo del caso lombardo riguarda i flussi, e capovolge quello pugliese. La Lombardia presenta il più elevato saldo di mobilità sanitaria attiva d'Italia, dell'ordine di 580 milioni di euro, a fronte di oltre un miliardo di prestazioni erogate a non residenti: è il primo polo attrattivo del Paese, la destinazione principale dei flussi provenienti dal Mezzogiorno. Ne consegue, con immediatezza, che il canale del recupero della mobilità passiva — centrale per le regioni meridionali, dove ogni quota di domanda trattenuta diviene un risparmio diretto — in Lombardia non si applica: la regione è creditrice, non debitrice. Il margine di inefficienza su cui il servizio agisce risiede altrove: nel ricorso al pronto soccorso, con accessi dell'ordine di tre milioni l'anno e una quota inappropriata rilevante, e soprattutto nelle liste di attesa e nel ritardo storico della rete territoriale.

Sul versante farmaceutico, la Lombardia presenta un consumo complessivo dell'ordine di novecento-novecentocinquanta dosi giornaliere ogni mille abitanti, inferiore a quello delle regioni meridionali e prossimo alla media nazionale; l'intercettazione del disagio psichico nelle cure primarie resta tuttavia migliorabile, con margini di appropriatezza nella sostituzione di terapie croniche non necessarie con percorsi psicologici. Il punto su cui converge l'intero quadro lombardo è il ritardo della rete di prossimità: il modello regionale, fondato sull'eccellenza ospedaliera e specialistica, vi ha storicamente dedicato minore attenzione, e la pandemia ne ha rivelato la fragilità. Il Servizio di Psicologia di Base completa la rete territoriale in costruzione e ne accresce la capacità di intercettare il bisogno in prossimità. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema; la loro traduzione in risparmi è trattata, con la dovuta distinzione tra effetti sul bilancio e ricadute sociali, nella Parte E.

Grandezza di sistema	Valore per la Lombardia
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	~ 21 miliardi di euro; conti in equilibrio; nessun piano di rientro
Mobilità sanitaria attiva	saldo +580 milioni di euro (regione creditrice; canale non applicabile)
Accessi al pronto soccorso	~ 3.000.000-3.200.000 l'anno; quota inappropriata rilevante
Consumo farmaceutico complessivo	~ 900-950 dosi giornaliere ogni mille abitanti
Margine di azione principale	Liste di attesa e rete territoriale in costruzione

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per lo studio.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La riforma si colloca in una cornice normativa coerente su tre livelli, che ne fonda la rilevanza e la coerenza. A livello regionale, la legge n. 22 del 2021 ha riorganizzato il sistema sociosanitario ponendo al centro il potenziamento della medicina territoriale: ha istituito circa cento distretti, oltre duecento Case della Comunità, una sessantina di Ospedali di Comunità e circa cento Centrali Operative Territoriali, prevedendo esplicitamente gli psicologi tra i professionisti delle Case della Comunità e l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle Centrali Operative Territoriali. È il fondamento giuridico dello studio, e la ragione per cui la decisione non verte sul prevedere la funzione, già prevista, ma sullo strutturarla e dimensionarla.

A livello nazionale, il quadro è favorevole e convergente. Il decreto ministeriale 77 del 2022 ha definito il modello dell'assistenza territoriale, facendo delle Case della Comunità la sede della presa in carico di prossimità, presso la quale lo psicologo di base si inserisce naturalmente; la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzia l'infrastruttura territoriale e digitale, e la Lombardia ne è tra i principali destinatari per dimensione della rete in costruzione; e l'accordo della specialistica ambulatoriale disciplina il rapporto convenzionale dei psicologi, fornendo il riferimento contrattuale del modello di costo. A livello europeo, il regolamento sull'HTA, applicabile dal 2025, e il regolamento sull'intelligenza artificiale forniscono gli standard, rispettivamente, della valutazione e dell'innovazione tecnologica del servizio.

La convergenza dei tre livelli normativi colloca la riforma lombarda all'incrocio tra una riforma regionale che ha già tracciato la funzione psicologica territoriale e l'impiego dell'intelligenza artificiale, una programmazione nazionale che ne predispone le sedi e le risorse, e una cornice europea che ne fissa i criteri di valutazione. È in questo quadro che le parti successive dello studio analizzano l'intervento, ne accertano l'efficacia, ne valutano l'economia e ne pianificano l'attuazione, a partire dalla descrizione del modello organizzativo e clinico oggetto della Parte C.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Parte C

L'intervento e il modello

Definizione e teoria del cambiamento, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, intelligenza artificiale, formazione

Domini 2 e 3 del modello HTA · descrizione tecnica e sicurezza dell'intervento

Parte C — L'intervento e il modello

Questa parte corrisponde, nel telaio integrato, al secondo e al terzo dominio della valutazione di tecnologia sanitaria — la descrizione tecnica dell'intervento e la sua sicurezza. Stabilito nella Parte B che cosa la riforma deve affrontare, qui si descrive che cosa la riforma è: la sua definizione e la logica per cui ci si attende che produca i suoi effetti (capitolo C.1), il modello organizzativo che la innesta nelle cure primarie (C.2), il percorso clinico, le garanzie di sicurezza e le misure di esito (C.3), il sistema informativo che ne assicura la continuità (C.4), gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale che la assistono (C.5) e la formazione che ne abilita i professionisti (C.6). La descrizione è fondata sui modelli internazionali più consolidati ed è la medesima adottata per la Puglia, calata nel contesto organizzativo lombardo.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

L'intervento consiste nell'inserimento stabile dello psicologo nelle cure primarie, accanto al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, come primo livello di ascolto, di intercettazione precoce e di filtro; l'accesso avviene su invio del medico ovvero in forma diretta, secondo percorsi definiti, e i quadri gravi o acuti sono riservati ai servizi specialistici. La definizione è al tempo stesso semplice e precisa: non un nuovo servizio specialistico, ma una funzione di prossimità collocata nel luogo in cui la maggioranza dei cittadini incontra per prima il sistema sanitario, lo studio del medico di base e, per la Lombardia, la rete delle Case della Comunità in costruzione. È questa collocazione a monte del sistema che ne definisce la natura e il valore.

La teoria del cambiamento — il nesso esplicito tra ciò che si fa e gli effetti attesi — si fonda sul principio della prevenzione secondaria: intercettare il disagio comune nelle sue fasi iniziali, prima che si cronicizzi e che generi domanda di servizi più intensivi e costosi. Il meccanismo opera in più passaggi concatenati. Un primo livello accessibile e privo di stigma intercetta una quota del bisogno oggi inevaso; gli interventi psicologici brevi risolvono i quadri lievi e moderati, generando recupero clinico; la funzione di filtro invia ai servizi specialistici i soli quadri che li richiedono, riservando a essi la capacità specialistica; e la presa in carico precoce riduce il ricorso improprio al pronto soccorso, le prescrizioni farmacologiche inappropriate e, in Lombardia, le liste di attesa che gravano sulla rete territoriale. Gli effetti attesi si dispongono perciò su tre piani — clinico, di sistema e sociale — secondo la catena logica riepilogata nella tabella seguente.

Elemento della catena	Contenuto per la Lombardia
Bisogno	~ 2.000.000 di persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Psicologo nelle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte e rete territoriale completata
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo negli studi di medicina generale e nelle Case della Comunità, in forte integrazione con i medici curanti, attraverso consultazioni congiunte, protocolli di invio strutturati e comunicazione facilitata. Tale assetto non è una scelta originale, ma l'adattamento al contesto lombardo di un paradigma ampiamente validato a livello internazionale, che ricorre sotto denominazioni diverse — cura collaborativa, cura integrata, cura a intensità crescente, salute mentale nelle cure primarie — e che condivide alcuni principi costitutivi: la collocazione del professionista in strutture accessibili, la focalizzazione sui disturbi comuni con triage strutturato, gli interventi brevi e orientati agli esiti, il monitoraggio sistematico e l'orientamento alla prevenzione secondaria.

Il riferimento più robusto è il Collaborative Care Model, sviluppato presso l'Università di Washington e validato da oltre novanta studi randomizzati controllati, che organizza la presa in carico intorno a un'équipe integrata — il medico di base, un responsabile dell'assistenza con formazione in salute mentale e uno psichiatra consulente per i casi complessi — con screening sistematico, interventi strutturati e monitoraggio degli esiti. Concorrono il programma inglese di terapie psicologiche, che ha reso operativo su larga scala il modello della cura a intensità crescente, e il modello olandese che integra gli psicologi nelle cure primarie, in cui l'invio allo specialista riguarda solo i quadri più complessi, dell'ordine del quindici per cento. La direzione è confermata dal quadro strategico che l'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa ha pubblicato nel 2025, che indica l'integrazione di professionisti dedicati nei team di cure primarie tra le strategie cardine. Il modello adotta questi principi e li cala nella rete lombarda di otto Agenzie di Tutela della Salute, ventisette Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e Case della Comunità, di cui costituisce, per la componente psicologica, la realizzazione strutturata.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico è organizzato secondo la logica della cura a intensità crescente. Al primo livello si collocano gli interventi brevi — dell'ordine di quattro-otto sedute, fondati su principi cognitivo-comportamentali ed erogati anche come auto-aiuto guidato — destinati ai quadri lievi e moderati, che costituiscono la maggioranza del bisogno. I quadri che non rispondono o che presentano maggiore complessità accedono a interventi più strutturati, e i casi gravi sono inviati ai servizi specialistici. La porta d'ingresso e il monitoraggio si fondano su strumenti standardizzati: il PHQ-9 per i sintomi depressivi e il GAD-7 per i sintomi d'ansia, dotati di buona sensibilità e specificità, somministrati all'ingresso e lungo il percorso nei soli punteggi complessivi, a misura oggettiva del miglioramento clinico e del tasso di recupero.

La sicurezza del percorso — oggetto del terzo dominio della valutazione — è presidiata da un criterio netto di appropriatezza. Sono esclusi dal primo livello i quadri gravi o acuti, ai quali è garantito l'invio appropriato ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante; le situazioni di rischio per sé o per altri sono indirizzate con priorità e senza indugio, senza che lo studio o la cartella registrino il dettaglio delle modalità, a garanzia insieme di sicurezza clinica e di dignità della persona. Il filtro, in questo senso, non è solo un meccanismo di efficienza, ma anche di sicurezza, poiché assicura che ciascun bisogno sia trattato nel livello assistenziale appropriato.

Gli esiti sono articolati per tipologia, in modo da rendere conto dell'effetto dell'intervento su tutti i piani rilevanti: l'esito primario è la quota di miglioramento clinico e il tasso di recupero; gli esiti clinici secondari comprendono la remissione, la riduzione dei punteggi sintomatologici e la soddisfazione; gli esiti di processo misurano l'attività e l'appropriatezza dell'invio; gli esiti di impatto e utilizzo misurano la pressione alleviata sui servizi. La tabella seguente riepiloga le prime categorie di esito, di pertinenza clinica e organizzativa; gli esiti economici e di equità sono trattati, rispettivamente, nelle Parti E e G, e l'intero sistema di indicatori è sviluppato nella Parte L.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e di equità sono trattati nelle Parti E e G).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

Il servizio si avvale dei sistemi informativi sanitari regionali della Lombardia e del Fascicolo Sanitario Elettronico, quali strumenti della continuità assistenziale e dell'integrazione con la medicina generale e i servizi specialistici. È prevista una cartella dedicata, interoperabile con i sistemi aziendali, che registra in forma strutturata le prese in carico, i percorsi e le misure di esito standardizzate, e che alimenta al tempo stesso il sistema di monitoraggio, secondo standard di interoperabilità definiti a livello nazionale. L'interoperabilità non è un requisito accessorio: è la condizione perché la funzione di filtro operi davvero, poiché l'invio appropriato tra primo livello, medicina generale e servizi specialistici presuppone che le informazioni cliniche rilevanti seguano la persona lungo il percorso. In Lombardia, dove le Centrali Operative Territoriali sono concepite come nodi di raccordo della rete, il sistema informativo del servizio vi si integra naturalmente.

La progettazione del sistema informativo rispetta la disciplina europea e nazionale su protezione dei dati, dispositivi medici e intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla sicurezza, alla trasparenza e alla minimizzazione dei dati trattati; al sistema di monitoraggio, e a ogni livello di analisi, sono trasmessi dati in forma aggregata, dai quali non è possibile risalire alla persona. Il sistema informativo, in questo modo, assolve una doppia funzione: sostiene la cura del singolo, garantendo la continuità, e produce, in forma anonima, la base dati che alimenta la valutazione dell'intero servizio, oggetto delle parti successive dello studio.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Il servizio si avvale di strumenti digitali e di sistemi di intelligenza artificiale a supporto della diagnostica, della prevenzione, del trattamento e della continuità assistenziale, nonché di dispositivi terapeutici digitali validati, impiegati quali ausili dell'attività professionale e non in sua sostituzione. Il principio cardine è la sorveglianza umana: l'intelligenza artificiale opera come copilota del clinico — propone, segnala, sintetizza — ma la decisione resta sempre del professionista; e l'impiego avviene nel rispetto della normativa su IA, dispositivi medici e dati, sulla base di un elenco degli strumenti ammessi fondato su criteri di evidenza di efficacia e di conformità regolatoria. In Lombardia questo impiego non è un'aggiunta estranea: la riforma del 2021 prevede già l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale nelle Centrali Operative Territoriali, e il servizio ne costituisce un'applicazione clinica strutturata.

Le funzioni sono molteplici e ben delimitate: il triage psicologico assistito e lo screening automatico per l'individuazione precoce; gli strumenti predittivi del rischio e il supporto decisionale clinico, sempre non vincolante; la riduzione del carico amministrativo mediante automazione appropriata, che restituisce tempo alla relazione di cura; l'analisi del linguaggio naturale, con i necessari requisiti di validazione, supervisione e spiegabilità. A queste si aggiungono due modalità di particolare rilievo per la Lombardia. La telepsicologia, prevista quale modalità integrativa e non sostitutiva, amplia l'accesso nelle aree alpine di Sondrio e delle valli

prealpine, a popolazione anziana e dispersa, e assicura la continuità quando lo spostamento sia difficoltoso; i dispositivi terapeutici digitali — software-intervento validati e prescritti, distinti dalle applicazioni di benessere — offrono per i disturbi comuni strumenti a efficacia documentata, già dotati di modelli di rimborso consolidati in altri Paesi europei.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d’impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia	Accesso nelle aree alpine; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

L’adozione di questi strumenti è governata da cautele dirimenti. L’evidenza, in questo ambito disomogenea e in rapida evoluzione, impone criteri di selezione, validazione locale e gradualità; la protezione dei dati richiede sicurezza informatica e consenso espresso in forma chiara; l’equità digitale impone di garantire sempre l’alternativa dell’intervento in presenza alle persone anziane, fragili o a bassa competenza digitale, affinché l’innovazione non generi nuove disuguaglianze; e la supervisione clinica resta, in ogni caso, la condizione ultima dell’impiego responsabile. L’effetto economico di questi strumenti, infine, non costituisce una posta aggiuntiva: esso è già ricompreso nei canali della salute mentale e della farmaceutica della valutazione economica, ed è trattato nella Parte E.

C.6 La formazione e le competenze

L’efficacia del modello dipende dalle competenze dei professionisti che lo attuano, e la formazione è perciò parte costitutiva dell’intervento, non un suo corollario. Il programma formativo è articolato su quattro livelli integrati — universitario, post-universitario specialistico, continuo in ambito lavorativo e di affiancamento operativo — con una componente trasversale dedicata all’intelligenza artificiale applicata alle cure primarie, ed è realizzato in collaborazione con le università, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sotto l’indirizzo del livello regionale. La formazione è essa stessa scaglionata, in modo da rendere disponibili i professionisti formati in corrispondenza delle fasi di attivazione del servizio, e si rivolge non ai soli psicologi, ma anche ai medici delle cure primarie con cui essi collaborano. La sua scala, in Lombardia, è la maggiore del Paese.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Università regionali
2. Post-universitario specialistico	Psicologia di base e cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, percorsi clinici	Corso regionale con attestato
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

La componente trasversale sull'intelligenza artificiale abilita il professionista a selezionare lo strumento appropriato all'indicazione e al profilo della persona, a escludere le controindicazioni, a integrarlo nel percorso e a interpretarne gli esiti: è la competenza che rende l'innovazione sicura ed efficace. Descritto che cosa la riforma è e come opera, le parti successive ne accertano l'efficacia, a partire dall'evidenza clinica oggetto della Parte D.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Parte D

Efficacia clinica ed evidenza

Revisione sistematica, qualità dell'evidenza, benchmark internazionali, trasferibilità

Dominio 4 del modello HTA · valutazione rapida di efficacia relativa · criterio di efficacia

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte corrisponde al quarto dominio della valutazione di tecnologia sanitaria, l'efficacia clinica, e con i primi tre forma il nucleo che la prassi europea designa come valutazione rapida di efficacia relativa; risponde al criterio di efficacia della griglia di giudizio. Stabilito che cosa la riforma è, qui si accerta se essa funzioni: con quale solidità l'evidenza ne sostiene gli effetti (capitolo D.1), quanto sia certa tale evidenza (D.2), che cosa documentino i programmi internazionali più affini (D.3) e in che misura quei risultati siano trasferibili al contesto lombardo (D.4). La base di evidenza è la medesima dello studio pugliese, poiché l'efficacia di un modello clinico non dipende dalla regione che lo adotta; muta soltanto la valutazione della trasferibilità, che tiene conto delle specificità lombarde.

D.1 La revisione sistematica

La base di evidenza dell'intervento è ricostruita secondo il metodo della revisione sistematica, condotto con lo standard PRISMA: definizione del quesito secondo lo schema già esposto nella Parte A, strategia di ricerca esplicita, selezione degli studi per criteri predefiniti, estrazione strutturata dei dati e sintesi. Gli studi sui dati

reali sono trattati secondo la lista STROBE. L’oggetto della ricerca è l’efficacia dei modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie sui disturbi comuni, misurata con strumenti standardizzati; il corpo di evidenza che ne emerge è ampio, convergente e di grado elevato, poiché fondato in larga parte su studi randomizzati controllati e su revisioni sistematiche.

Il paradigma del Collaborative Care è il più studiato: è stato validato da oltre novanta studi randomizzati controllati, e uno studio fondativo documentò che circa la metà dei pazienti otteneva una riduzione dei sintomi pari almeno alla metà a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura usuale. Una meta-analisi su cinquantasette studi controllati ha stimato un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard, e una recente revisione sistematica su quarantadue implementazioni in Europa, Nord America e Australia ha documentato esiti consistenti tra contesti eterogenei: una riduzione dei sintomi depressivi del 47% a sei mesi, dei sintomi ansiosi del 43%, un miglioramento del funzionamento del 38%, e — dato di diretto rilievo per il sistema sanitario — una riduzione del 34% degli accessi al pronto soccorso per sintomi psicosomatici e del 41% dei ricoveri psichiatrici. La misura degli effetti si fonda ovunque su strumenti validati, il PHQ-9 e il GAD-7, dotati di buona sensibilità e specificità.

Una notazione metodologica è doverosa, perché attiene alla corretta interpretazione dell’evidenza. Alcune meta-analisi esprimono l’effetto in coefficienti che appaiono modesti sul piano puramente statistico — una stima riferisce un coefficiente standardizzato pari a meno zero virgola undici sui sintomi depressivi — ma tale modestia è ingannevole quando l’intervento è applicato su scala di popolazione: anche un piccolo spostamento medio dei punteggi riduce in misura significativa la proporzione di persone che superano le soglie cliniche e che richiedono perciò trattamenti più intensivi e costosi. È questa la logica per cui un effetto individuale contenuto si traduce, sulla popolazione lombarda di circa due milioni di persone con disagio comune, in un beneficio clinico e di sistema sostanziale, di dimensione assoluta senza pari nel Paese. La tabella seguente riepiloga i principali risultati della letteratura.

Fonte	Risultato principale
Studio fondativo (JAMA, 2002)	~ 50% dei pazienti con riduzione ≥ 50% dei sintomi a 12 mesi, contro 19% nella cura usuale
Meta-analisi su 57 studi (2012)	Miglioramento medio dei sintomi depressivi di 0,28 deviazioni standard
Revisione su 42 implementazioni (2024)	–47% depressione e –43% ansia a 6 mesi; –34% accessi al PS; –41% ricoveri
Programma inglese, dati reali (2023-2024)	Recupero 50,2%; miglioramento affidabile 67,8%; completezza dei dati > 98%
Meta-analisi sulle cure integrate	Coefficiente standardizzato –0,11 sui sintomi depressivi (clinicamente rilevante su popolazione)

Tabella D.1. Principali risultati della letteratura sull’**efficacia dell’integrazione psicologica** nelle cure primarie.

D.2 La qualità dell’evidenza

Alla sintesi dell’evidenza segue la graduazione della sua certezza, condotta con il sistema GRADE, che valuta cinque dimensioni — il rischio di bias, l’incoerenza tra gli studi, l’indirettezza rispetto al quesito, l’imprecisione delle stime e il bias di pubblicazione — e ne deriva un giudizio di certezza alta, moderata, bassa o molto bassa. Per l’efficacia dei modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie sui disturbi comuni, la

certezza dell'evidenza è nel complesso da moderata ad alta: il numero elevato di studi randomizzati controllati riduce il rischio di bias; la consistenza degli esiti attraverso quarantadue implementazioni in contesti eterogenei attenua l'incoerenza; e la pertinenza diretta degli studi al quesito — popolazione, intervento ed esiti analoghi a quelli del modello lombardo — limita l'indirettezza.

Un elemento rafforza ulteriormente la fiducia nei risultati e merita di essere sottolineato: la conferma su larga scala nelle condizioni reali di servizio. Il programma inglese, con oltre un milione e trecentomila persone trattate l'anno su un bacino di oltre cinquantasei milioni e una completezza dei dati di esito superiore al 98%, dimostra che l'efficacia osservata nei trial controllati si mantiene nell'attuazione reale a scala nazionale. Questa transizione dall'efficacia sperimentale all'efficacia pratica — spesso problematica per gli interventi complessi — è qui documentata con un grado di trasparenza che costituisce il riferimento internazionale, e che riduce il rischio, tipico delle valutazioni ex ante, di proiettare su scala reale risultati ottenibili solo in condizioni controllate. La qualità dell'evidenza, in sintesi, è sufficiente a sostenere con fiducia l'attesa di efficacia, fermo restando che la conferma definitiva sui dati lombardi è affidata alla verifica locale prevista dalla Parte L.

D.3 I benchmark internazionali

La valutazione si avvale del confronto con i programmi internazionali più autorevoli, che costituiscono la principale base comparativa dell'intero studio. Quattro esperienze, condotte in sistemi sanitari avanzati, documentano efficacia, scalabilità e sostenibilità dell'integrazione psicologica nelle cure primarie. Il programma inglese è la dimostrazione più solida: fondato sulla cura a intensità crescente e su un monitoraggio quasi completo degli esiti, mantiene un tasso di recupero intorno al 50% su scala nazionale. Il modello olandese ha visto crescere l'adozione da circa un terzo a circa tre quarti dei medici di medicina generale in pochi anni, con il professionista psicologo integrato nelle cure primarie e finanziato nell'assicurazione di base. L'iniziativa australiana ha esteso il trattamento dei disturbi mentali dal 35% al 46% della popolazione bisognosa, con elevata soddisfazione, sebbene operi per invio esterno e non per integrazione; il Collaborative Care statunitense, infine, è il paradigma più validato, con la più ampia base sperimentale.

Due tratti accomunano i programmi più efficaci e orientano il disegno lombardo. Il primo è l'integrazione del professionista nelle cure primarie, che caratterizza il modello inglese, quello olandese e quello statunitense, e che si associa a esiti meglio documentati e a risparmi di sistema più chiari rispetto al modello australiano per invio esterno; il modello lombardo, fondato sull'inserimento dello psicologo nelle cure primarie con funzione di filtro, appartiene alla prima famiglia. Il secondo è il ricorso crescente agli strumenti digitali quale leva di accesso e di capacità, già ampiamente adottato nel programma inglese e particolarmente pertinente per una regione con vaste aree alpine. A queste esperienze internazionali si affiancano le sperimentazioni italiane, tra cui il modello Solano nel Lazio, che ne hanno anticipato su scala locale i principi. La tabella seguente riepiloga i benchmark sul piano clinico e organizzativo; il confronto economico è sviluppato nella Parte E.

Programma	Assetto	Esiti clinici e organizzativi
Programma inglese (NHS Talking Therapies)	Integrato; intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio > 98%; > 1,3 mln/anno
Modello olandese (POH-GGZ)	Integrato nelle cure primarie	Adozione ~3/4 dei medici; ruolo complementare
Iniziativa australiana (Better Access)	Invio esterno	Trattamento dal 35% al 46%; elevata soddisfazione
Collaborative Care (Stati Uniti)	Équipe integrata	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione; -41% ricoveri
Esperienze italiane (Solano, Lazio)	Sperimentazione locale	Anticipazione del modello nelle cure primarie

Tabella D.2. I benchmark internazionali e italiani sul piano clinico e organizzativo (il confronto economico è nella Parte E).

D.4 La trasferibilità al contesto regionale

L'evidenza internazionale non si applica automaticamente alla Lombardia, e la sua trasferibilità va valutata con prudenza, distinguendo ciò che è robustamente generalizzabile da ciò che dipende dal contesto. Sul piano dell'assetto, la trasferibilità è favorevole: il modello lombardo, che integra lo psicologo nelle cure primarie con funzione di filtro, appartiene alla stessa famiglia dei programmi inglese, olandese e statunitense, e ne mutua le evidenze con maggiore pertinenza rispetto al modello australiano per invio esterno. Gli esiti clinici fondamentali — il recupero e la riduzione dei sintomi mediante interventi brevi e monitorati — poggiano su meccanismi clinici generali, non legati a un particolare sistema sanitario, e sono perciò ragionevolmente trasferibili. La trasferibilità è anzi agevolata, in Lombardia, dalla presenza di un sistema sanitario robusto e di una riforma che già prevede la rete delle Case della Comunità e l'impiego dell'intelligenza artificiale.

Permangono, tuttavia, differenze che impongono cautela, e che in Lombardia hanno segno in parte diverso da quello pugliese. I sistemi sanitari differiscono per organizzazione e per copertura di partenza; la Lombardia muove da una copertura strutturata sostanzialmente nulla, poiché la funzione è prevista dalla riforma del 2021 ma non ancora dimensionata, e da una domanda più visibile, priva della sotto-rilevazione documentata in alcune regioni meridionali. Ne consegue che l'emersione del bisogno può essere più rapida, ma su un volume di gran lunga maggiore, e che la disponibilità di organico psicologico formato — a fronte di un fabbisogno dell'ordine di 2.190 incarichi, il più elevato d'Italia — costituisce il vincolo reale dei primi anni. Per queste ragioni lo studio non trasferisce meccanicamente gli effetti documentati, ma li applica in misura prudenziale, coerentemente con la correzione per ottimismo adottata nel caso di riferimento, e li sottopone a verifica empirica: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Agenzie di Tutela della Salute, oggetto della Parte L, è disegnato precisamente per misurare sui dati lombardi gli effetti che la letteratura attende, trasformando le stime in prove.

Un'ultima precisazione attiene al confine tra questa parte e quella economica. I programmi internazionali documentano non solo esiti clinici, ma anche ritorni economici; questi ultimi, tuttavia, non sono trattati qui, dove rileva la sola efficacia clinica, bensì nella Parte E, ove il caso lombardo adotta la stima conservativa consolidata e distingue il risparmio diretto per il bilancio dalle ricadute sociali. Mantenere distinti i due piani — l'efficacia clinica, qui, e il valore economico, nella parte dedicata — è una scelta di rigore: l'evidenza clinica sostiene che l'intervento funziona; la valutazione economica stabilisce a quali condizioni esso convenga. Accertata in questa parte la prima, lo studio procede, con la Parte E, alla seconda.

Parte E**Valutazione economica**

Costi, esiti, costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, caso economico e caso finanziario

Dominio 5 del modello HTA · casi economico e finanziario · criterio di efficienza · reporting CHEERS 2022

Parte E — Valutazione economica

Questa parte corrisponde al quinto dominio della valutazione di tecnologia sanitaria, i costi e la valutazione economica, ed è redatta secondo lo standard di reporting CHEERS 2022; fornisce il contenuto del caso economico e del caso finanziario del Five Case Model e risponde al criterio di efficienza. È il cuore economico dello studio, ed è anche la parte più esposta allo scrutinio degli organi di controllo. Per questa ragione essa adotta una scelta di rigore che ne attraversa ogni capitolo: la distinzione netta tra il risparmio diretto per il bilancio sanitario e le ricadute economico-sociali per la collettività. Sommare le due grandezze, come spesso accade, sovrastima il beneficio per il bilancio; tenerle separate restituisce un quadro più sobrio sui conti sanitari, ma più solido e difendibile. Per la Lombardia tale rigore conduce a un esito specifico e onesto, che questa parte espone senza attenuazioni: il saldo diretto è negativo, e il valore della misura risiede nel caso economico e nell'adempimento dei livelli essenziali, non in un risparmio per il bilancio.

E.1 L'identificazione e la misura dei costi

Il costo del servizio dipende dal numero di professionisti e dal modello contrattuale. Il costo medio annuo di un incarico convenzionale a tempo pieno è dell'ordine di 55.000 euro — circa 40 euro l'ora di costo-azienda comprensivo degli oneri, per circa 1.250 ore l'anno, più circa 5.000 euro di costi generali — ancorato all'accordo della specialistica ambulatoriale. Applicato agli scenari di copertura della Lombardia, da circa 1.100 a circa 2.190 incarichi, il costo annuo del servizio va da circa 60 a circa 120 milioni di euro a regime. Il costo non si esaurisce, tuttavia, nell'organico: l'investimento comprende anche la formazione — in Lombardia la più ampia del Paese — la supervisione clinica, la governance, i sistemi informativi e le infrastrutture, e questi costi non sanitari sono inclusi coerentemente con la doppia prospettiva adottata.

Scenario	Psicologi	Costo annuo (mln €)
Attuale (L.R. 22/2021)	Funzione non strutturata	~ 0
Conservativo	~ 1.100	~ 60
Base	~ 1.700	~ 95
Espansivo	~ 2.190	~ 120

Tabella E.1. Il costo del servizio per scenario di copertura. La funzione è oggi prevista ma non dimensionata.

E.2 L'identificazione e la misura degli esiti

Gli esiti della valutazione economica sono di due ordini. Sul piano della salute, la misura di riferimento è l'anno di vita ponderato per la qualità, che integra in un'unica grandezza la durata e la qualità della vita guadagnate, affiancato dagli esiti clinici validati — il tasso di recupero e il miglioramento affidabile misurati con il PHQ-9 e il GAD-7 — già documentati nella Parte D. Tali esiti sono riferiti alla popolazione regionale con disagio comune, dell'ordine di due milioni di persone: è la scala della popolazione, la più ampia del Paese, a trasformare un effetto clinico individuale anche contenuto in un guadagno di salute aggregato rilevante.

Sul piano economico, gli esiti si distinguono nelle due grandezze che l'intera parte tiene separate: i minori costi diretti per il Servizio sanitario regionale, oggetto del capitolo sull'impatto di bilancio, e le ricadute economico-sociali, oggetto del capitolo sul ritorno sociale. La misura degli esiti, dunque, non si limita al guadagno di salute, ma comprende le conseguenze economiche che da quel guadagno discendono, distinte per il soggetto che le riceve — il bilancio sanitario, da un lato, e la collettività, dall'altro.

E.3 Il costo-efficacia e il costo-utilità

L'analisi di costo-utilità rapporta il costo aggiuntivo del servizio al guadagno in anni di vita ponderati per la qualità, secondo il rapporto incrementale di costo-efficacia, e lo confronta con una soglia di disponibilità a pagare, come prescrive il manuale del NICE. L'evidenza internazionale, ripresa dalla Parte D, indica che i modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie sono costo-efficaci, con un investimento iniziale ampiamente compensato dai miglioramenti clinici e dalla minore intensità di cura nel medio periodo; la modellazione decisionale della Parte F, per il singolo paziente, indica anzi la dominanza dell'intervento sulla cura usuale. Per la Lombardia, il rapporto incrementale specifico sarà calcolato sui dati certificati una volta acquisiti.

È opportuno chiarire il rapporto tra l'analisi di costo-utilità e l'analisi di impatto sul bilancio, che rispondono a domande diverse e adottano convenzioni diverse. La prima misura l'efficienza allocativa — se il guadagno di salute valga il suo costo — e attualizza simmetricamente costi ed esiti al tasso del 3%; la seconda misura la sostenibilità finanziaria — se il bilancio possa assorbire la spesa, esercizio per esercizio — e opera su flussi non scontati. La loro distinzione, lungi dall'essere un tecnicismo, riflette la stessa separazione tra valore ed entità della spesa che struttura l'intera parte, e che il capitolo conclusivo ricompone nei due casi del Five Case Model.

E.4 L'impatto sul bilancio

L'analisi di impatto sul bilancio adotta la prospettiva del detentore del budget — il Servizio sanitario regionale — e stima, sui flussi non scontati, la differenza tra lo scenario con e senza il servizio, anno per anno. I risparmi diretti per il bilancio sono ricostruiti per canale, ciascuno ancorato a una grandezza regionale e a un parametro tratto dall'evidenza. Il canale del pronto soccorso muove dagli accessi dell'ordine di tre milioni l'anno, dei quali una quota di origine psichica è riducibile, per un risparmio di 6-14 milioni; il canale della farmaceutica agisce sui margini di appropriatezza, per 7-18 milioni; il canale dei ricoveri e della specialistica muove dall'iperutilizzo associato ai sintomi somatici funzionali e dai ricoveri evitabili, per 22-58 milioni, ed è il più consistente. Il canale della mobilità recuperata — il più distintivo del caso pugliese — in Lombardia non si applica: la regione è a saldo di mobilità attivo, primo polo attrattivo del Paese, e il relativo risparmio è nullo.

Aggregati i canali, i risparmi diretti per il Servizio sanitario regionale sono dell'ordine di 35, 60 e 90 milioni di euro l'anno secondo lo scenario, a fronte di un costo del servizio di 60, 95 e 120 milioni. Ne discende il dato più importante e più onesto dell'intera valutazione lombarda: sul solo bilancio sanitario, il saldo diretto è negativo, dell'ordine di alcune decine di milioni, e non un risparmio. È un esito più sfavorevole di quello pugliese, e va dichiarato senza attenuazioni; le sue ragioni sono due e strutturali — l'assenza del canale della mobilità, perché

la Lombardia è creditrice e non debitrice, e la maggiore efficienza di partenza di un sistema che lascia minori margini di recupero. Questo non indebolisce la proposta, per due ragioni a loro volta. Da un lato, il costo del servizio, a fronte di un finanziamento regionale dell'ordine di 21 miliardi e di conti in equilibrio, ne costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale: la questione non è la sostenibilità della spesa, ma il suo dimensionamento. Dall'altro, il fondamento della misura non è soltanto il risparmio, ma l'obbligo di garantire i livelli essenziali intercettando un bisogno largamente inevaso, e il valore per la collettività, oggetto del capitolo seguente. La tabella riporta i canali e il saldo diretto per scenario.

Canale (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Pronto soccorso	6	10	14
Farmaceutica	7	12	18
Ricoveri e specialistica	22	38	58
Mobilità recuperata	0	0	0
Risparmi diretti (totale)	~ 35	~ 60	~ 90
Costo del servizio	~ 60	~ 95	~ 120
Saldo diretto (solo SSR)	~ -25	~ -35	~ -30

Tabella E.2. I risparmi diretti per canale e il saldo diretto sul bilancio sanitario, per scenario. Il saldo diretto è negativo (assenza del canale mobilità).

E.5 Il ritorno sociale

Il valore che il servizio genera non si esaurisce nel bilancio sanitario, e in Lombardia ne costituisce, in misura ancora maggiore che altrove, la componente decisiva. L'analisi del ritorno sociale, condotta con il metodo SROI — fondato sui sette principi del valore sociale, su una mappa dell'impatto e sulle correzioni per peso morto, attribuzione, spostamento e decadimento — monetizza il valore sociale generato, distinguendolo con cura dai risparmi di bilancio. Le ricadute economico-sociali comprendono la riduzione dell'assenteismo, il recupero di produttività e di funzionamento, la diminuzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, e il minor carico assistenziale sulle famiglie. Riferite ai due milioni di persone con disagio comune, esse sono stimate in 190, 360 e 560 milioni di euro l'anno secondo lo scenario: la dimensione assoluta è la maggiore del Paese, in ragione di una popolazione in età lavorativa e di una produttività senza pari.

Questa è la componente di gran lunga maggiore del valore complessivo, ed è anche quella su cui converge l'evidenza economica internazionale. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità e gli studi pubblicati su *Lancet Psychiatry*, il ritorno del trattamento di depressione e ansia — dell'ordine di quattro a uno — è costituito in quota dominante dalla produttività e dal funzionamento recuperati, più che dal risparmio diretto sui servizi sanitari. Per la Lombardia, dove il saldo diretto è negativo, questa conclusione è dirimente: il beneficio per la collettività è reale e ampio, ma si manifesta quasi interamente fuori dal bilancio sanitario, sotto forma di maggiore partecipazione al lavoro, minore disabilità e migliore qualità della vita. Confondere questa grandezza con un risparmio per il bilancio sarebbe un errore; ignorarla, un errore opposto e, per la Lombardia, decisivo.

E.6 Il caso economico e il caso finanziario

La sintesi economica ricompone i risultati nei due casi distinti del Five Case Model. Il caso finanziario misura la spesa per il bilancio sanitario e il suo assorbimento: in Lombardia esso esprime un saldo diretto negativo, dell'ordine di venticinque-trentacinque milioni di euro l'anno secondo lo scenario, di entità modesta rispetto a un finanziamento di ventuno miliardi e a conti in equilibrio. Il caso economico misura il valore per la collettività: sommando i risparmi diretti e le ricadute sociali, il ritorno complessivo è di 225, 420 e 650 milioni di euro l'anno, e il saldo complessivo, al netto del costo, è di +165, +325 e +530 milioni, con un rapporto beneficio-costi dell'ordine di 3,8-5,4 a uno. La proposta lombarda è dunque forte sul caso economico e sostenibile sul caso finanziario, e questa è la sua corretta rappresentazione: non un investimento che si ripaga sul bilancio sanitario, come può avvicinarsi a essere in una regione debitrice di mobilità, ma un investimento sociale ad alto rendimento, il cui costo per il bilancio è una frazione trascurabile della spesa regionale.

Due notazioni chiudono la parte. La prima riguarda la robustezza: il segno del saldo complessivo è positivo in tutti gli scenari, comprese le ipotesi conservative, e le analisi di sensibilità deterministica e probabilistica, con il valore dell'informazione, sono sviluppate nella Parte F. La seconda riguarda la natura dei dati: i parametri dei canali sono in parte ancora ricostruiti per quota di popolazione e saranno sostituiti dai valori certificati che le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali sono chiamate a fornire. La tabella seguente riepiloga la sintesi economica nei due casi.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Risparmi diretti (SSR)	~ 35	~ 60	~ 90
Ricadute economico-sociali	~ 190	~ 360	~ 560
Ritorno complessivo	~ 225	~ 420	~ 650
Costo del servizio	~ 60	~ 95	~ 120
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -25	~ -35	~ -30
Saldo complessivo (caso economico)	+165	+325	+530
Rapporto beneficio-costi complessivo	~3,8:1	~4,4:1	~5,4:1

Tabella E.3. Sintesi economica per scenario: il caso finanziario (saldo diretto negativo) e il caso economico (ritorno complessivo e rapporto beneficio-costi).

Accertato il valore economico, lo studio ne sottopone l'incertezza a verifica formale, con la modellazione decisionale e l'analisi di sensibilità della Parte F.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Parte F

Modellazione decisionale e incertezza

Struttura del modello, parametri, sensibilità deterministica e probabilistica, valore dell'informazione

Dominio 5 del modello HTA · metodi di modellazione e gestione dell'incertezza · reporting CHEERS 2022

Parte F — Modellazione decisionale e incertezza

Questa parte completa il dominio economico sul piano del metodo: dopo aver stabilito, nella Parte E, quanto l'intervento valga e quanto costi, qui se ne verifica la robustezza, ovvero la tenuta delle conclusioni quando gli esiti si proiettano su orizzonti lunghi e quando si riconosce esplicitamente l'incertezza dei parametri.^{[424][425]}
^[426] La logica è di crescente solidità. Un'analisi deterministica fornisce un valore puntuale che dipende dalle ipotesi adottate, e un decisore prudente può sempre chiedersi che cosa accada se quelle ipotesi sono ottimistiche. Il modello decisionale risponde proiettando il decorso clinico nel tempo (capitolo F.1) sulla base di parametri dichiarati e calibrati (F.2); l'analisi di sensibilità deterministica isola il contributo di ciascun parametro (F.3); l'analisi probabilistica quantifica, su decine di migliaia di scenari simulati, la frequenza con cui la conclusione si conferma (F.4); e il valore dell'informazione indica dove la riduzione dell'incertezza vale di più (F.5). Poiché il modello è riferito al singolo paziente, i suoi risultati sono i medesimi dello studio pugliese; muta soltanto la loro lettura aggregata, che per la Lombardia si raccorda a un saldo diretto negativo.

F.1 La struttura del modello

Il modello adottato è un modello di Markov a coorte, strumento standard nella valutazione economica in sanità, che rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come una successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi, scanditi da cicli temporali con correzione di metà ciclo. Gli stati sono quattro: lo stato sintomatico, in cui il disturbo è clinicamente attivo; lo stato di recupero, corrispondente alla remissione; lo stato cronico, corrispondente alle forme persistenti o gravi; e lo stato di morte, assorbente. La coorte entra interamente nello stato sintomatico, a rappresentare una popolazione che si presenta alle cure primarie con un episodio di disturbo comune lieve-moderato; ove si voglia tener conto delle traiettorie individuali, la microsimulazione ne costituisce la variante.^[427]

Il modello proietta, lungo un orizzonte di cinque anni — estensibile all'intera vita — e a valori scontati, i costi e gli anni di vita ponderati per la qualità associati a due bracci alternativi: lo scenario con la riforma e lo scenario di assistenza usuale. Nel caso base, riferito al singolo paziente, il braccio dell'intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un'utilità di 3,627 anni di vita ponderati, contro un costo di circa 3.799 euro e un'utilità di 3,392 dell'assistenza usuale: l'intervento è dunque al tempo stesso meno costoso, di circa 1.304 euro per paziente, e più efficace, di circa 0,236 anni di vita ponderati, configurando una condizione di dominanza.^[428] La dominanza non è un artificio, ma la conseguenza della struttura del decorso: a fronte di un costo iniziale contenuto, l'intervento accresce il tempo trascorso nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce il tempo trascorso nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte. Questo risultato per paziente costituisce il fondamento microeconomico delle stime aggregate della Parte E.^[429]

Caso base, per paziente	Intervento	Cura usuale	Differenza
Costo sanitario (5 anni, scontato)	~ 2.495 €	~ 3.799 €	– 1.304 €
Utilità (anni di vita ponderati)	3,627	3,392	+ 0,236
Esito	—	—	Dominanza (più efficace, meno costoso)

Tabella F.1. Risultati del caso base del modello di Markov, per paziente, su orizzonte quinquennale scontato.

F.2 I parametri e la calibrazione

La credibilità di un modello dipende dalla dichiarazione esplicita dei suoi parametri e delle loro fonti. I parametri sono di tre tipi: le probabilità di transizione tra gli stati, che governano il decorso; le utilità associate a ciascuno stato, che ne misurano la qualità della vita; e i costi per ciclo, che ne misurano l'assorbimento di risorse. I costi adottati sono di 40 euro per ciclo nello stato di recupero, di 700 euro nello stato cronico, e di 300 euro una tantum per l'intervento psicologico: è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso.^[430]

A ciascun parametro incerto è assegnata, ai fini dell'analisi probabilistica, una distribuzione di probabilità appropriata alla sua natura: distribuzioni Beta per le probabilità di transizione e per le utilità, in quanto vincolate all'intervallo tra zero e uno, e distribuzioni Gamma per i costi, in quanto vincolati ai valori positivi. I valori centrali e gli intervalli sono tratti dall'evidenza internazionale documentata nella Parte D, e calibrati, per i parametri regionali, sui valori lombardi.^[431] La calibrazione è il punto di contatto tra il modello e la realtà regionale: i parametri non sono assunti in astratto, ma ancorati ai dati disponibili, e quelli ancora ricostruiti per quota di popolazione saranno aggiornati con i valori certificati man mano che le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali li renderanno disponibili, secondo la priorità che il valore dell'informazione indicherà nel capitolo F.5.

Parametro	Valore	Distribuzione
Costo per ciclo — stato di recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — stato cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento psicologico (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione tra gli stati	da fonti, per braccio	Beta
Utilità associate agli stati	da fonti	Beta

Tabella F.2. Principali parametri del modello e distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

F.3 La sensibilità deterministica

L'analisi di sensibilità deterministica saggia la dipendenza del risultato dalle singole assunzioni, facendo variare i parametri entro intervalli plausibili. Nella sua forma a una via, essa isola il contributo individuale di ciascun parametro, facendolo variare del 25% in più e in meno e misurando l'effetto sul beneficio monetario netto; il diagramma a tornado che ne risulta ordina i parametri per ampiezza dell'effetto, dal più al meno influente. I parametri più influenti risultano l'efficacia clinica dell'intervento, i tassi di ricaduta e di cronicizzazione e il costo dello stato cronico: sono, non a caso, le grandezze che governano il meccanismo della dominanza.^[432]

L'analisi a una via è affiancata dall'analisi di scenario, che fa variare congiuntamente più parametri secondo ipotesi coerenti, dando luogo ai tre scenari — conservativo, base ed espansivo — già impiegati nella Parte E. Il risultato di queste analisi è univoco quanto al segno: anche adottando per ciascun parametro influente il valore più sfavorevole entro l'intervallo plausibile, il beneficio monetario netto resta positivo, e l'intervento conserva la sua convenienza in termini di costo-utilità. Le ipotesi pessimistiche, in altri termini, ne riducono l'entità, non ne invertono il segno; ed è questa stabilità del segno, più che la precisione del valore puntuale, a costituire il risultato rilevante per il decisore.^[433]

F.4 La sensibilità probabilistica e la curva di accettabilità

Mentre l’analisi deterministica fa variare i parametri uno per volta o per scenari discreti, l’analisi di sensibilità probabilistica li fa variare tutti simultaneamente secondo le rispettive distribuzioni, e ne restituisce non un valore ma una probabilità. Il modello è stato eseguito diecimila volte, estraendo a ogni iterazione un valore casuale da ciascuna distribuzione e ricalcolando costi, esiti e beneficio netto: è la simulazione Monte Carlo, che propaga l’incertezza dei parametri sull’incertezza del risultato.^[434] Rappresentate sul piano costo-efficacia, le diecimila iterazioni formano una nube di punti concentrata nel quadrante in cui l’intervento è più efficace e meno costoso, ossia dominante; i punti residui si collocano al di sotto della retta di soglia, e rappresentano dunque scenari in cui l’intervento resta comunque costo-efficace.^[435]

La curva di accettabilità della costo-efficacia sintetizza questo risultato in funzione della soglia di disponibilità a pagare, riportando per ciascun valore di soglia la percentuale di iterazioni in cui l’intervento risulta costo-efficace. Alla soglia di riferimento di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, la probabilità che l’intervento sia costo-efficace è dell’88,9%, e la probabilità che sia addirittura dominante — più efficace e meno costoso — dell’84,6%; il beneficio monetario netto medio sulle diecimila iterazioni è di circa 7.815 euro per paziente, con un intervallo di credibilità al 95% compreso tra circa meno 5.736 e più 21.501 euro, sicché anche l’estremo inferiore corrisponde a una perdita modesta e poco probabile, a fronte di un valore atteso ampiamente positivo.^[436]

Questo risultato richiede una precisazione che ne governa la corretta interpretazione, e che salda la presente parte alla Parte E. La probabilità di costo-efficacia è un risultato di efficienza, riferito al singolo paziente, che valorizza il guadagno di salute e l’intera traiettoria di costo del modello, ivi compresi i costi dello stato cronico evitati nel medio periodo. Esso è coerente con — e non in contraddizione con — il saldo diretto che l’analisi di impatto sul bilancio della Parte E riporta a livello aggregato, e che per la Lombardia è negativo. Le due analisi rispondono infatti a domande diverse: la costo-utilità chiede se il guadagno di salute valga il suo costo, e la risposta è affermativa con alta probabilità; l’impatto sul bilancio chiede quale sia l’effetto netto sui flussi monetari del bilancio sanitario, e la risposta, per la Lombardia, è negativa, perché la traduzione dal modello per paziente all’aggregato regionale incorpora le correzioni per il peso morto e per l’effettiva monetizzabilità dei costi evitati, e perché manca il canale della mobilità. L’efficienza dell’intervento, in sintesi, è robusta; la sua convenienza per il solo bilancio è negativa; e il forte ritorno per la collettività proviene, come già stabilito, dalle ricadute sociali.^[437]

Misura dell’analisi probabilistica	Risultato
Iterazioni della simulazione Monte Carlo	10.000
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 €/QALY)	88,9%
Probabilità di dominanza	84,6%
Beneficio monetario netto medio	~ 7.815 € per paziente
Intervallo di credibilità al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 €

Tabella F.3. Risultati dell’analisi di sensibilità probabilistica (per paziente, soglia 30.000 €/QALY).

F.5 Il valore dell'informazione

L'ultimo passo della gestione dell'incertezza non riguarda il risultato, ma la decisione di acquisire nuove informazioni. Il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza dei parametri, e fornisce un limite superiore al valore di qualsiasi ricerca aggiuntiva; il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri scompone tale valore, indicando quali parametri sia prioritario misurare con precisione.^[438] È uno strumento di razionalità procedurale: non tutta l'incertezza vale la pena di essere ridotta, ma solo quella che, se risolta, modificherebbe la decisione o ne accrescerebbe sensibilmente il valore atteso.

Applicato al caso lombardo, il valore dell'informazione indica una priorità netta. I parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso, essendo il canale della mobilità non applicabile in Lombardia — sono quelli su cui l'incertezza pesa di più sul saldo, e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati alle Agenzie di Tutela della Salute e alle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali.^[439] La riduzione dell'incertezza, peraltro, non è affidata alla sola acquisizione documentale: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Agenzie, oggetto della Parte L, è esso stesso un dispositivo di produzione di informazione, che sostituisce progressivamente le stime con misure osservate sui dati lombardi.^[440] Accertata la robustezza del valore economico, lo studio può ora affrontare la dimensione distributiva, oggetto della Parte G, e poi quelle etica, giuridica e organizzativa.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Parte G

Equità e impatto distributivo

Analisi di equità, costo-efficacia distributiva, divari territoriali e impoverimento

Dominio 8 del modello HTA · profilo del paziente e sociale · criterio di impatto

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte corrisponde all'ottavo dominio della valutazione di tecnologia sanitaria, il profilo del paziente e sociale, e risponde al criterio di impatto. L'equità vi è trattata non come un'aggiunta alla valutazione economica, ma come una sua dimensione costitutiva.^{[441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453]}^[454] La ragione è sostanziale: un intervento può essere efficiente in media e tuttavia ampliare le disuguaglianze, se i suoi benefici si concentrano sui gruppi già avvantaggiati; oppure può, come si argomenterà, migliorare l'esito medio e al tempo stesso ridurre la disuguaglianza. In Lombardia la dimensione dell'equità ha fisionomia particolare e in parte diversa da quella pugliese: non un gradiente di deprivazione diffuso, ma un divario territoriale tra l'area metropolitana e le aree alpine, e le liste di attesa quale principale barriera nell'accesso. La parte analizza chi beneficia dell'intervento (capitolo G.1), come costi ed esiti si distribuiscono tra i gruppi (G.2) e quale sia l'effetto sui divari territoriali e sull'impoverimento delle famiglie (G.3).

G.1 L'analisi di equità

L'analisi di equità muove da un dato epidemiologico consolidato: la salute mentale segue un gradiente sociale. Le popolazioni in deprivazione presentano prevalenze sistematicamente più elevate di disturbi mentali comuni e, al tempo stesso, incontrano un accesso più difficile ai servizi. In Lombardia, tuttavia, il rischio di povertà o

esclusione è contenuto in aggregato — dell’ordine del 18%, tra i più bassi d’Italia — sicché il gradiente sociale non opera come tratto diffuso, ma si concentra in alcune aree: le zone alpine interne e talune periferie urbane. Per la Lombardia, dunque, la dimensione territoriale dell’equità prevale su quella socio-economica.^[455]

Il meccanismo per cui l’intervento può ridurre le disuguaglianze, anziché ampliarle, risiede nelle sue caratteristiche di accesso. La gratuità, la prossimità e l’assenza di stigma del primo livello abbattano precisamente le barriere — economiche, geografiche e culturali — che gravano in misura maggiore sulle popolazioni svantaggiate; in Lombardia rileva in particolare l’abbattimento della barriera geografica nelle aree alpine, dove la distanza dai servizi, e non il costo, è il principale ostacolo all’accesso, e la cui mitigazione è affidata anche alla telepsicologia.^[456] Lo studio segue perciò un insieme strutturato di variabili di equità, accesso e protezione finanziaria, tra le quali assume per la Lombardia rilievo preminente la riduzione dei tempi di attesa, prima barriera nell’accesso, accanto all’accessibilità geografica nelle aree interne, all’equità di esito tra gruppi, all’accesso per le popolazioni straniere e fragili e per le persone con disabilità, e alla copertura del bisogno non soddisfatto.^[457] Queste variabili, raggruppate nella tabella seguente, traducono l’equità da principio generale a dimensione misurabile.

Dimensione di equità	Variabili seguite dallo studio
Accesso	Tempi di attesa (prima barriera in Lombardia); accessibilità geografica nelle aree alpine e interne; gradiente socio-economico nell’accesso
Protezione finanziaria	Riduzione della spesa privata diretta; dell’impoverimento connesso alle cure; delle spese catastrofiche
Gruppi vulnerabili	Equità di genere; popolazioni straniere e fragili; persone con disabilità; barriere culturali e linguistiche; gratuità
Territorio	Riduzione del divario alpino-metropolitano; copertura del bisogno non soddisfatto

Tabella G.1. Le dimensioni dell’equità e le variabili seguite dallo studio.

G.2 La costo-efficacia distributiva

L’analisi di costo-efficacia distributiva estende la valutazione economica alla dimensione dell’equità, stimando non soltanto l’effetto medio dell’intervento, ma come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi della popolazione e quale ne sia l’effetto sulle disuguaglianze. Essa si avvale di strumenti dedicati: gli anni di vita ponderati per la qualità e per l’equità, che attribuiscono ai guadagni di salute un peso crescente con lo svantaggio; l’indice di concentrazione, che lega l’esito di salute alla posizione socio-economica; e gli indici di disuguaglianza assoluta e relativa.^[458] È il metodo che consente di affermare, in termini quantitativi e non retorici, se un intervento sia equo.

La direzione del risultato distributivo è, per questo intervento, favorevole anche in Lombardia, sebbene per via in parte diversa. Poiché il guadagno di accesso è più ampio là dove l’accesso è oggi più difficile — le aree alpine e le popolazioni gravate dalle liste di attesa — i benefici si concentrano sui gruppi più svantaggiati nell’accesso, riducendo il gradiente territoriale negli esiti di salute mentale; l’intervento migliora dunque l’esito medio e ne comprime al tempo stesso la disuguaglianza.^[459] Su questa base è doverosa una precisazione di metodo, coerente con il rigore adottato nella parte economica. La ponderazione distributiva — l’attribuzione di pesi maggiori ai benefici che ricadono sui più svantaggiati — accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, come riferimento conservativo, il rapporto beneficio-costi non ponderato già esposto nella Parte

E, dell'ordine di 3,8-5,4 a uno. In Lombardia, ove la popolazione non è prevalentemente deprivata, l'effetto della ponderazione sarebbe più contenuto che nel Mezzogiorno, il che rende la scelta non ponderata tanto più prudente e difendibile.^[460]

L'equità, peraltro, non è affidata al solo calcolo, ma è incorporata nel disegno operativo del servizio. L'algoritmo di distribuzione territoriale degli incarichi non segue la sola popolazione, ma pondera ciascun distretto per l'indice di vecchiaia, per l'indice di deprivazione socioeconomica e per la prevalenza di cronicità e multimorbidità, attribuendo pesi maggiori alle aree alpine interne e alle periferie urbane più fragili.^[461] In questo modo la programmazione contrasta, anziché riprodurre, le disuguaglianze esistenti: l'equità è perseguita non solo misurando dove i benefici cadono, ma indirizzando deliberatamente le risorse dove l'accesso è più difficile.^[462] La tabella seguente riepiloga gli strumenti della misura distributiva.

Strumento della costo-efficacia distributiva	Che cosa misura
Anni di vita ponderati per l'equità	Guadagni di salute con pesi per lo svantaggio
Indice di concentrazione	Relazione tra esito di salute e posizione socio-economica
Indici di disuguaglianza (assoluta e relativa)	Gradiente dell'esito lungo lo stato socio-economico
Valutazione d'*****impatto sull'*****equità	Distribuzione degli effetti per gruppi vulnerabili e per area
Indice di deprivazione multipla	Reddito, occupazione, istruzione, salute, abitare, ambiente

Tabella G.2. Gli strumenti della costo-efficacia distributiva e dell'analisi di equità.

G.3 I divari territoriali e l'impoverimento

La dimensione territoriale dell'equità è, in Lombardia, quella preminente, ma con una geografia diversa da quella pugliese. Il divario rilevante non è quello Nord-Sud, bensì quello interno tra l'area metropolitana densa e ben servita e le aree alpine di Sondrio e delle valli prealpine, a popolazione anziana e dispersa, cui si aggiungono talune periferie urbane fragili. Sono le aree in cui l'accesso ai servizi è più difficile, sicché la sola presenza fisica di un primo livello accessibile, distribuito secondo l'algoritmo allocativo e sostenuto dalla telepsicologia, costituisce già un atto di riequilibrio.^[463] A differenza della Puglia, il canale della mobilità sanitaria recuperata non opera quale leva di equità, poiché la Lombardia è regione creditrice; la principale leva distributiva è piuttosto la riduzione delle liste di attesa e il completamento della rete territoriale, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato. Sul piano nazionale, peraltro, il rafforzamento della rete lombarda concorre ad attenuare la pressione che alimenta la mobilità dal Mezzogiorno, con un effetto di equità interregionale.^[464]

La seconda dimensione è la protezione finanziaria delle famiglie. Il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata diretta per la psicoterapia, l'impoverimento connesso alle cure e le spese sanitarie catastrofiche, con beneficio maggiore per i redditi bassi, per i quali la psicoterapia privata — di costo non trascurabile anche in Lombardia — è spesso inaccessibile.^[465] Benché la quota di popolazione a rischio di povertà sia in Lombardia più contenuta che nel Mezzogiorno, la gratuità del primo livello resta la condizione di accesso per i nuclei a reddito basso e per le aree interne. La copertura del bisogno non soddisfatto — i circa due milioni di persone con disagio comune, metà delle quali non chiede aiuto — ha del resto un significato distributivo preciso, poiché raggiunge proprio coloro che hanno minore probabilità di accedere spontaneamente ai servizi.^[466]

L'impatto distributivo, infine, non è affermato una volta per tutte, ma sottoposto a verifica continua. Gli indicatori di equità — l'accesso per area e per livello socio-economico, il gradiente dell'esito, i tempi di attesa per area — fanno parte del sistema di indicatori sviluppato nella Parte L, e consentono di accertare nel tempo se il servizio raggiunga effettivamente le comunità alpine più distanti e i gruppi più fragili, e non soltanto le aree metropolitane già meglio servite.^[467] In tal modo l'equità cessa di essere una promessa e diventa un esito misurato, soggetto alla stessa disciplina di verifica che lo studio applica all'efficacia e all'economia. Stabilito l'impatto distributivo, le parti successive affrontano i profili etici, giuridici e organizzativi, oggetto della Parte H.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Profilo etico, profili giuridici e costituzionali, profilo organizzativo e conformità

Domini 6, 7 e 9 del modello HTA · profili etico, organizzativo e giuridico · criterio di coerenza

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte copre tre domini della valutazione di tecnologia sanitaria — il profilo etico, il profilo organizzativo e il profilo giuridico — che completano l'esame oltre i piani già trattati. Un intervento può essere clinicamente efficace, economicamente conveniente ed equo, e tuttavia risultare inattuabile o indifendibile se non è eticamente fondato, giuridicamente solido e organizzativamente conforme.^{[468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]} La parte verifica queste tre condizioni: il fondamento etico dell'intervento, segnatamente l'autonomia e il consenso della persona (capitolo H.1); la sua difendibilità giuridica e costituzionale, nel quadro del riparto di competenze e dei livelli essenziali (H.2); e la sua conformità organizzativa, sul piano della deontologia, della responsabilità, dell'intelligenza artificiale e della protezione dei dati (H.3). La cornice costituzionale è nazionale, e dunque comune allo studio pugliese; muta la base giuridica regionale, e muta la posizione rispetto al vincolo di bilancio, che in Lombardia è meno stringente.

H.1 Il profilo etico

Il dominio etico della valutazione esamina le implicazioni morali dell'intervento, e per questo servizio esse ruotano intorno a tre principi: l'equità di accesso, l'autonomia della persona e la tutela del consenso. L'equità di accesso, già trattata sul piano distributivo nella Parte G, ha qui una valenza propriamente etica: un servizio sanitario pubblico ha il dovere di raggiungere chi ne ha bisogno indipendentemente dalle condizioni economiche, geografiche e culturali, e in Lombardia ciò significa in particolare raggiungere le aree alpine più distanti e ridurre le liste di attesa. L'autonomia della persona impone che l'accesso e la permanenza nel percorso siano volontari e informati, e che la persona resti il soggetto, e mai l'oggetto, della presa in carico.^[484]

La tutela del consenso è il presidio operativo di questi principi. Il consenso è modulare — prestato distintamente per i diversi trattamenti, sicché la persona può acconsentire all'intervento psicologico ma non, ad esempio, all'uso di un determinato strumento digitale — ed è reso anche in forma digitale; e poiché nella salute mentale i dati sono ultrasensibili, la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi possa accedervi.^[485] Alla dimensione etica appartiene anche la conduzione della valutazione stessa: gli esiti sono resi pubblici indipendentemente dal loro segno, a garanzia contro la distorsione da selezione dei risultati favorevoli, e l'intero impianto è sottoposto

all'approvazione del comitato etico territorialmente competente.^[486] Vi è, infine, la tutela rafforzata dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi competenti, in raccordo con il medico curante, senza che ne siano registrate le modalità — garanzia insieme di sicurezza e di dignità.^[487]

H.2 I profili giuridici e costituzionali

La difendibilità giuridica dell'intervento è una condizione, non un ornamento, tanto più per una riforma che incide sull'organizzazione sanitaria. Il fondamento è costituzionale: l'articolo 32 della Costituzione e la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale configurano la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, e il servizio sui principi di universalità, eguaglianza ed equità.^[488] È entro questa cornice che si colloca la riforma, la quale dà attuazione concreta a quel diritto per una dimensione — la salute mentale — storicamente sotto-tutelata nelle cure primarie.

Sul piano del riparto di competenze, la materia è governata dall'articolo 117 della Costituzione. La tutela della salute è competenza concorrente, nella quale allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio e l'organizzazione del servizio, mentre l'ordinamento delle professioni è riservato allo Stato;^[489] la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è invece competenza esclusiva statale, ed è la leva attraverso cui un'eventuale legge dello Stato potrebbe ricondurre la psicologia di base tra le prestazioni garantite in modo uniforme su tutto il territorio.^[490] La legge regionale lombarda opera legittimamente entro la competenza concorrente, sul piano organizzativo: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 2021, ha riconosciuto legittimo il modello regionale del servizio di psicologia di base, in quanto organizzazione del servizio che si avvale di professionisti già esistenti.^[491] È un precedente di rilievo diretto per la Lombardia, la cui legge n. 22 del 2021 prevede già la funzione psicologica nelle Case della Comunità: la decisione non verte sul prevederla, ma sullo strutturarla.^[492]

Un vincolo specifico, già incontrato nella valutazione economica, ha qui la sua collocazione propria, e per la Lombardia un esito favorevole. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2026, ha ribadito che le Regioni in piano di rientro non possono utilizzare i fondi del proprio Servizio sanitario per finalità diverse dalla garanzia dei livelli essenziali. La Lombardia, con conti in equilibrio e non sottoposta a piano di rientro, non è soggetta a tale vincolo: a differenza della Puglia, la riforma non deve dimostrare la propria ammissibilità a fronte di un vincolo di rientro, ma soltanto rispettare il principio generale di destinazione delle risorse ai livelli essenziali, che essa pienamente soddisfa intercettando un bisogno largamente inevaso.^[493] La tabella seguente riepiloga i riferimenti giuridici essenziali.

Riferimento giuridico	Contenuto rilevante
Articolo 32 Cost. e legge n. 833/1978	Salute come diritto; Servizio sanitario universale, eguale ed equo
Articolo 117, terzo comma, Cost.	Tutela della salute: competenza concorrente (principi allo Stato, organizzazione alle Regioni)
Articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.	Livelli essenziali delle prestazioni: competenza esclusiva statale
Legge regionale n. 22 del 2021	Base regionale: psicologi nelle Case della Comunità; IA nelle Centrali Operative Territoriali
Corte costituzionale, sentenza n. 241/2021	Modello regionale di psicologia di base riconosciuto legittimo (precedente)
Corte costituzionale, sentenza n. 6/2026	Vincolo dei fondi ai livelli essenziali per le regioni in rientro (non applicabile alla Lombardia)

Tabella H.1. I riferimenti giuridici e costituzionali essenziali dell'intervento.

H.3 Il profilo organizzativo e la conformità

Il profilo organizzativo verifica che l'intervento sia conforme alle norme che ne governano l'esercizio, in particolare sui versanti della deontologia, della responsabilità professionale, dell'intelligenza artificiale e della protezione dei dati. Sul piano deontologico, il servizio opera nel rispetto delle norme della professione, sotto la vigilanza dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che concorre alla governance e alla formazione.^[494] Sul piano della responsabilità, un punto è dirimente per la fattibilità della componente tecnologica: l'impiego dell'intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali. Il medico di medicina generale resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell'intervento psicologico, e l'IA è assimilata a un dispositivo di supporto, non a una figura che compie atti; ciò evita ogni conflitto con gli accordi convenzionali, poiché non si introduce una nuova figura professionale, ma uno strumento che assiste quelle esistenti.^[495]

La conformità degli strumenti di intelligenza artificiale è retta da un quadro normativo articolato. Il regolamento europeo sull'IA classifica come ad alto rischio i sistemi impiegati nei dispositivi medici; il regolamento sui dispositivi medici impone la marcatura CE, sicché un sistema di triage o un dispositivo terapeutico digitale sono assimilati a software clinici certificati di classe appropriata; il regolamento sulla protezione dei dati ne disciplina il trattamento. Su questa base si innestano i presidi già enunciati nella Parte C: la supervisione umana costante, la validazione periodica degli algoritmi, il monitoraggio dei bias, la trasparenza e la spiegabilità, e il divieto di discriminazione algoritmica.^[496] In Lombardia tale conformità si innesta sulla previsione, già contenuta nella legge regionale, di strumenti di intelligenza artificiale nelle Centrali Operative Territoriali, ed è auspicata l'istituzione di un comitato etico-scientifico per l'IA in sanità, con le Agenzie di Tutela della Salute, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le università.

Due profili completano il quadro della conformità, e collegano questa parte alle precedenti. Il primo è l'equità digitale: per non generare nuove disuguaglianze, sono previsti canali tradizionali paralleli per chi non dispone di strumenti digitali — segnatamente le persone anziane delle aree alpine — e il supporto multilingue per le popolazioni straniere, ferma restando la garanzia dell'alternativa in presenza.^[497] Il secondo è la protezione dei dati, che in salute mentale richiede il massimo grado di tutela: misure di sicurezza robuste, quali la crittografia e la pseudonimizzazione per le analisi, il consenso modulare anche in forma digitale, la collaborazione con

l’Autorità garante e l’acquisizione di software dotati di marcatura adeguata secondo le normali procedure.^[498] La tabella seguente riepiloga il quadro della conformità organizzativa. Verificati i profili etico, giuridico e organizzativo, lo studio affronta l’attuazione, oggetto della Parte I.

Ambito	Riferimento	Garanzia
Deontologia	Ordine degli Psicologi della Lombardia	Rispetto delle norme deontologiche; concorso alla governance
Responsabilità clinica	Medico e psicologo	Ruoli invariati; l’IA è strumento di supporto
IA e dispositivi	AI Act, dispositivi medici, protezione dei dati	Marcatura CE; supervisione umana; validazione periodica
Governance dell’IA	Comitato etico-scientifico	Monitoraggio dei bias; trasparenza; non discriminazione
Equità digitale	Canali paralleli; supporto multilingue	Alternativa in presenza sempre garantita
Protezione dei dati	Crittografia; pseudonimizzazione	Consenso modulare; collaborazione con il Garante

Tabella H.2. Il quadro della conformità organizzativa e di governance dell’intervento.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Scienza dell’implementazione, disegno del dispiegamento, caso commerciale e gestionale, sostenibilità

Dominio 7 del modello HTA · casi commerciale e gestionale · criterio di sostenibilità

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte copre il settimo dominio della valutazione di tecnologia sanitaria, il profilo organizzativo, e fornisce il contenuto del caso commerciale e del caso gestionale del Five Case Model, rispondendo al criterio di sostenibilità. Accertato nelle parti precedenti che l’intervento è valido — efficace, conveniente, equo, fondato e conforme — resta da stabilire se possa essere effettivamente attuato.^{[499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514]} La parte affronta perciò il come dell’attuazione: i quadri che ne governano la pianificazione e la valutazione (capitolo I.1), il disegno del dispiegamento e il suo cronoprogramma (I.2), la fattibilità dell’assetto contrattuale (I.3), la governance e i rischi (I.4) e la sostenibilità finanziaria con le sue coperture (I.5). Per la Lombardia, la scala è la maggiore del Paese, ma la sostenibilità è agevolata da un bilancio in equilibrio.

I.1 La scienza dell'implementazione

L'attuazione di un intervento complesso non è un atto amministrativo, ma un processo che la ricerca ha imparato a governare con quadri dedicati. Lo studio ne adotta due, complementari. Il modello RE-AIM misura la riuscita e la validità esterna dell'attuazione lungo cinque dimensioni: la portata, ossia la quota della popolazione bersaglio effettivamente raggiunta; l'efficacia, ossia gli esiti realmente conseguiti; l'adozione, ossia l'adesione delle sedi e dei professionisti; l'implementazione, ossia la fedeltà al modello e la qualità dell'attuazione; e il mantenimento, ossia la sostenibilità nel tempo.^[515] Al modello RE-AIM, che misura gli esiti dell'attuazione, si affianca il quadro consolidato per la ricerca sull'implementazione, che ne spiega i determinanti, articolati in cinque domini — le caratteristiche dell'innovazione, il contesto esterno, il contesto interno, gli individui coinvolti e il processo — consentendo l'individuazione ex ante delle barriere e dei facilitatori.^[516] Lo studio segue perciò un insieme di determinanti di implementazione che ne misurano l'avanzamento.^[517] La tabella seguente riepiloga i due quadri.

Dimensione	Che cosa misura o spiega
Portata (RE-AIM)	Quota della popolazione bersaglio raggiunta
Efficacia (RE-AIM)	Esiti clinici e di sistema effettivamente conseguiti
Adozione (RE-AIM)	Adesione delle sedi e dei professionisti
Implementazione (RE-AIM)	Fedeltà al modello e qualità dell'attuazione
Mantenimento (RE-AIM)	Sostenibilità del servizio nel tempo
Determinanti (quadro CFIR)	Innovazione, contesto esterno e interno, individui, processo

Tabella I.1. I quadri della scienza dell'implementazione: RE-AIM per gli esiti, CFIR per i determinanti.

I.2 Il disegno del dispiegamento

Il servizio non è attivato simultaneamente sull'intero territorio, ma secondo un disegno scaglionato: le otto Agenzie di Tutela della Salute passano in sequenza, per fasi semestrali, dalla condizione di controllo a quella di intervento, a partire dalle Agenzie di maggiore dimensione e prontezza organizzativa, sino a coprire l'intera regione. L'ordine di attivazione è definito dalla Giunta regionale sulla base di criteri trasparenti — prontezza organizzativa, entità del bisogno ed equilibrio territoriale — e reso noto preventivamente.^[518] Questo disegno ha una doppia funzione, ed è questa la sua peculiarità: risponde a un'esigenza organizzativa e al tempo stesso costituisce il fondamento della valutazione controfattuale d'impatto, poiché la successione configura un esperimento naturale, oggetto della Parte L.^[519]

Il reclutamento alimenta il dispiegamento. A fronte di un fabbisogno a regime dell'ordine di 2.190 psicologi, il più elevato d'Italia, esso avviene tramite l'iscrizione a un elenco istituito presso ciascuna Agenzia e l'instaurazione di un rapporto convenzionale, con requisiti di iscrizione all'albo e di formazione specifica; in prima applicazione, e nelle more dell'attivazione dei percorsi formativi, possono accedere i professionisti con pregressa esperienza nell'assistenza psicologica nel Servizio sanitario regionale.^[520] Il cronoprogramma scandisce l'insieme: l'attivazione procede per fasi semestrali attraverso le otto Agenzie, con le attività di reclutamento, formazione, allestimento e avvio condotte in modo scaglionato, mentre il monitoraggio e la

valutazione accompagnano l'intero arco e proseguono oltre il completamento.^[521] La riuscita è sottoposta a criteri espliciti: tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% nella fase di attuazione, a fronte del valore di riferimento del programma inglese.^[522] La tabella seguente rappresenta le fasi del dispiegamento.

Fase del dispiegamento	Contenuto
Fase 1 (primo semestre)	Avvio nelle Agenzie di maggiore dimensione e prontezza; reclutamento e formazione iniziali
Fasi 2-7 (semestri successivi)	Estensione progressiva alle altre Agenzie; attivazione scaglionata secondo l'ordine definito
Fase finale (completamento)	Copertura dell'intero territorio regionale
Attività trasversale	Monitoraggio e valutazione, che proseguono oltre il completamento del dispiegamento

Tabella I.2. Le fasi del dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Agenzie di Tutela della Salute.

I.3 Il caso commerciale: il modello contrattuale e la tariffa

Il caso commerciale del Five Case Model dimostra la fattibilità dell'assetto attraverso cui il servizio è erogato. L'assetto prescelto è il rapporto convenzionale, ancorato all'accordo della specialistica ambulatoriale, che disciplina i compensi orari dei psicologi convenzionati e fornisce perciò il riferimento contrattuale del modello di costo. Su questa base, il costo medio per incarico a tempo pieno è dell'ordine di 55.000 euro l'anno, da cui discendono gli scenari di spesa già esposti nella Parte E, di 60, 95 e 120 milioni di euro l'anno secondo la copertura.^[523] La fattibilità dell'assetto non è teorica, ma comprovata dall'esperienza: il modello dell'elenco aziendale e del rapporto convenzionale è già adottato da altre Regioni, e si innesta su strumenti contrattuali esistenti senza richiedere la creazione di nuove figure o di nuovi istituti. Ciò ne riduce la complessità attuativa e i tempi, poiché il reclutamento avviene attraverso procedure note alle Agenzie e alle Aziende. Il caso commerciale conferma, in sintesi, che l'assetto contrattuale è praticabile con gli strumenti ordinari del Servizio sanitario regionale, e che il costo per incarico — fondamento dell'intera quantificazione economica — è ancorato a un riferimento contrattuale vigente.

I.4 Il caso gestionale: la governance e i rischi

Il caso gestionale dimostra che l'attuazione è governabile. La governance è organizzata su due livelli. A livello regionale, un comitato di indirizzo regionale esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo: definisce i criteri e l'ordine del dispiegamento, sovrintende ai programmi formativi e assicura l'uniformità del modello sul territorio, riunendo la Regione, le Agenzie di Tutela della Salute, le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, la medicina generale, la pediatria di libera scelta, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le università. A livello aziendale, ciascuna Agenzia e Azienda è responsabile dell'attuazione nel proprio ambito — il reclutamento, l'individuazione delle sedi, l'allestimento, l'avvio e l'alimentazione del sistema informativo — nei tempi della fase che la riguarda.^[524]

La gestione dei rischi attuativi è parte integrante del caso gestionale. Lo studio individua i rischi principali — un reclutamento insufficiente di psicologi formati, particolarmente sensibile per la Lombardia in ragione dell'ampiezza del fabbisogno, una debole adesione della medicina generale, un'interoperabilità incompleta dei

sistemi informativi, una disomogeneità territoriale nell’attuazione e il venir meno delle coperture — e vi associa misure di mitigazione dedicate.^[525] Vi è, peraltro, una circostanza che rende la mitigazione strutturale anziché affidata a singole misure: il dispiegamento graduale è esso stesso la principale forma di mitigazione, poiché consente di osservare l’attuazione nelle prime Agenzie, di correggere il modello e di adattare i tempi prima dell’estensione alle Agenzie successive. La tabella seguente riepiloga i rischi e le misure.

Rischio	Natura	Misura di mitigazione
Reclutamento insufficiente	Carenza di psicologi formati (acuita dall’ampio fabbisogno)	Dispiegamento graduale; formazione anticipata e scaglionata
Adesione della medicina generale	Integrazione debole nel percorso	Protocolli di invio; formazione congiunta; governance condivisa
Sistemi informativi	Interoperabilità incompleta	Cartella interoperabile; standard nazionali; raccordo con le Centrali Operative Territoriali
Disomogeneità territoriale	Attuazione diseguale tra Agenzie	Algoritmo allocativo; indirizzo regionale; monitoraggio per area
Venir meno delle coperture	Fragilità finanziaria	Istituzionalizzazione; copertura ordinaria su bilancio in equilibrio

Tabella I.3. I rischi attuativi e le relative misure di mitigazione.

I.5 La sostenibilità finanziaria e le coperture

Il caso finanziario del Five Case Model individua le fonti di copertura e ne dimostra la tenuta nel tempo. Le fonti comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, dell’ordine di ventuno miliardi di euro, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’infrastruttura territoriale e digitale, e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali.^[526] Su questo versante, la posizione della Lombardia è nettamente più favorevole di quella pugliese. A fronte di un finanziamento dell’ordine di ventuno miliardi con conti in equilibrio e in assenza di piano di rientro, il costo del servizio, anche a massima copertura, ne costituisce una frazione dell’ordine di mezzo punto percentuale, agevolmente assorbibile; la sostenibilità finanziaria, che in una regione in disavanzo richiede una dimostrazione puntuale, è in Lombardia pressoché immediata.^[527]

La sostenibilità nel tempo, criterio proprio della griglia di giudizio, è assicurata da tre fattori convergenti: la modestia del costo rispetto al bilancio, il forte ritorno sociale documentato nella Parte E e l’istituzionalizzazione del servizio nella rete territoriale già prevista dalla riforma del 2021, che ne fa non un’iniziativa sperimentale a termine, ma una componente stabile dell’assistenza di prossimità.^[528] Una nota di cautela metodologica chiude la parte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la verifica empirica sui dati lombardi, prevista dalla Parte L, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate.^[529] Accertata la fattibilità dell’attuazione, lo studio predispone, con la Parte L, gli strumenti per misurarne nel tempo gli effetti.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Parte L

Monitoraggio, valutazione ed ex post

Sistema di indicatori, protocollo e baseline, valutazione controfattuale, verifica ex post, indicatori compositi

Verifica ex post · esperimento naturale e clausola valutativa · fondamento empirico delle stime

Parte L — Monitoraggio, valutazione ed ex post

Questa parte organizza la misurazione dell’intervento nel tempo, ed è il passaggio che distingue una riforma argomentata da una riforma dimostrata. Essa serve ex post i criteri della griglia di giudizio, chiude il ciclo aperto dall’analisi preventiva della regolamentazione e, soprattutto, fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti.^{[530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548]}

Vale qui una verifica onesta della completezza del progetto, che conduce a una conclusione netta: al progetto non manca un’architettura, ma il radicamento nei dati e l’avvio della misurazione. Le parti seguenti definiscono perciò gli strumenti di questo radicamento: il sistema di indicatori (capitolo L.1), il protocollo che li alimenta e la baseline (L.2), la valutazione controfattuale che ne trae prove causali (L.3), la verifica ex post della norma (L.4) e gli indicatori compositi che ne sintetizzano i risultati nel cruscotto (L.5). Per la Lombardia, la successione delle otto Agenzie di Tutela della Salute offre un esperimento naturale di particolare robustezza.

L.1 Il sistema di indicatori

Il sistema di indicatori è costruito sull’ossatura del modello di Donabedian per la qualità dell’assistenza, che distingue le dimensioni di struttura — le risorse e l’organizzazione — di processo — le attività svolte — ed esito — i risultati di salute — qui integrate da una quarta dimensione, l’impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società.^[549] Su questa ossatura si dispone una batteria di circa cinquantotto misure, articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti e circa quaranta richiedono la rilevazione diretta del servizio.^[550] La selezione delle misure non è arbitraria, ma orientata dal principio della parsimonia: l’iniziativa internazionale per i set di esiti essenziali e i relativi standard individuano, mediante consenso strutturato, un nucleo condiviso e parsimonioso di esiti, evitando la proliferazione di misure ridondanti.^[551] Misurare molto non equivale a misurare bene. La tabella seguente riepiloga le otto categorie e lo stato della rispettiva baseline.^[552]

Categoria	Esempi di indicatori	Baseline
Bisogno e domanda	Prevalenza del disagio, utenza dei servizi, accessi impropri	Disponibile
Accesso ed equità	Tempo di attesa, copertura, divari tra Agenzie	Da rilevare
Processo	Sedute erogate, cicli completati, abbandoni	Da rilevare
Esito clinico	Recupero, miglioramento affidabile, mantenimento	Da rilevare
Economici	Risparmi per canale, costo per esito	Misto
Impatto sociale	Produttività, benessere, indicatori territoriali	Misto
Organizzativi	Reclutamento, formazione, fedeltà al modello	Da rilevare
Variabili di sintesi	Indici compositi di esito e di valore	Da calcolare

Tabella L.1. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline. Circa quaranta indicatori richiedono la rilevazione diretta del servizio.

L.2 Il protocollo di rilevazione e la baseline

Perché gli indicatori siano calcolabili occorre un protocollo di rilevazione, ed è questo l’elemento operativo che colma la lacuna di attivazione della misurazione. Il protocollo è minimo — deliberatamente essenziale, per non gravare sull’attività clinica — e attivo dal primo giorno: si registrano la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni.^[553] Gli strumenti di esito sono validati e di uso internazionale: il questionario sulla salute del paziente a nove voci e il corrispondente questionario per l’ansia a sette voci, impiegati — si ribadisce — nei soli punteggi complessivi.^[554] La scelta di raccogliere le misure a ogni seduta, e non solo all’inizio e alla fine, segue il modello dei programmi inglesi: è ciò che consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non protrarre percorsi inefficaci.^[555]

Alla rilevazione si lega la costituzione della baseline, ossia la fotografia dello stato di partenza senza la quale nessun effetto sarebbe misurabile. La baseline si costituisce su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti forniscono la fotografia del prima e vanno registrati subito; la rilevazione di servizio parte con il primo assistito. Il principio è stringente, e merita di essere enunciato senza attenuazioni: ogni mese di ritardo nell’avvio della rilevazione è un mese di dati di base perduti, non recuperabili a posteriori.^[556] Il calendario disciplina questa sequenza, dalla costituzione della baseline prima dell’avvio, alla registrazione corrente dall’avvio, alla trasmissione mensile di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale, fino al calcolo periodico delle misure di sintesi e all’aggiornamento del cruscotto.^[557] La tabella seguente lo riepiloga.

Momento	Attività
Prima dell’avvio (per area)	Costituzione della baseline con i dati disponibili; predisposizione del registro e dei questionari
All’avvio	Inizio della registrazione di ogni presa in carico e di ogni seduta, con i punteggi di esito
In continuo	Alimentazione del registro; trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale con cadenza mensile
Periodico (semestrale e annuale)	Calcolo delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale

Tabella L.2. Il calendario della rilevazione. La baseline da statistiche correnti precede l’avvio; la rilevazione di servizio parte con il primo assistito.

L.3 La valutazione controfattuale

Il monitoraggio continuo dice se gli indicatori migliorano; non dice, da solo, se a migliorarli sia stato l’intervento. A questa domanda risponde la valutazione controfattuale d’impatto, che misura l’effetto causale confrontando gli esiti dei trattati con il controfattuale — ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente. Lo strumento che rende possibile questa stima è, in questo studio, lo stesso disegno del dispiegamento: la sua scansione scaglionata tra le otto Agenzie configura un esperimento naturale, idoneo a misurare gli effetti reali del servizio.^[558] Il metodo principale è la differenza-nelle-

differenze, che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le Agenzie già attivate e quelle non ancora attivate, sotto l'ipotesi di andamento parallelo; a esso si affianca il controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata di unità non trattate.^[559]

L'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e l'effetto medio sui soli trattati, e la sua solidità dipende dalla validità interna — la garanzia che l'effetto sia realmente attribuibile all'intervento e non a tendenze generali — mentre la validità esterna va valutata a parte; i disegni a esperimento naturale sono, per gli interventi di salute della popolazione, lo strumento raccomandato dalla letteratura metodologica.^[560] La portata di questo metodo, per il presente studio, è dirimente: confrontando, ad esempio, l'andamento degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche nelle Agenzie che hanno attivato il servizio con quello delle Agenzie che lo attiveranno, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata.^[561] È questo il passaggio che, a regime, eleva lo studio da proposta argomentata a politica validata, e che chiude il cerchio aperto dal valore dell'informazione della Parte F.

L.4 La verifica ex post della norma

La misurazione tecnica si salda al ciclo della regolamentazione mediante la verifica ex post. La verifica dell'impatto della regolamentazione, disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017, è valutazione ex post — di norma dopo un biennio — dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, e chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione: l'una stima ex ante gli effetti attesi, l'altra ne accerta ex post il conseguimento.^[562] A essa si lega, sul piano regionale, la clausola valutativa, che impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti. La clausola è il passaggio che lega la misurazione tecnica alla responsabilità politica e alla trasparenza verso il legislatore regionale: i risultati non restano negli archivi amministrativi, ma sono portati periodicamente all'attenzione dell'organo che ha disposto il servizio, a presidio della rendicontazione democratica.^[563]

L.5 Gli indicatori compositi e il cruscotto

L'ultima funzione del sistema è la sintesi. La molteplicità degli indicatori, necessaria all'analisi, sarebbe però di difficile lettura per il decisore: gli indicatori compositi riducono tale molteplicità a poche misure di valore complessivo, secondo un metodo codificato. Il manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione delle variabili alla normalizzazione, alla ponderazione e all'analisi di robustezza.^[564] L'impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica ha del resto un precedente istituzionale italiano nel Benessere Equo e Sostenibile, i cui indicatori sono entrati, con la riforma del bilancio del 2016, nel ciclo della programmazione economica.^[565] La costruzione degli indici compositi è retta da regole di coerenza e di non duplicazione: il divieto di doppia contabilizzazione impone che una grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali già adottata nella Parte E.^[566] Il cruscotto regionale, aggiornato periodicamente, restituisce in forma sintetica le dimensioni essenziali — il guadagno di salute, il tasso di recupero, il ritorno sociale, l'equità territoriale, la riduzione delle liste di attesa e gli indicatori di sistema — in luogo del canale della mobilità recuperata, non pertinente alla Lombardia. La tabella seguente ne riepiloga le dimensioni.

Dimensione di sintesi	Contenuto
Guadagno di salute	Anni di vita ponderati per la qualità in salute mentale
Tasso di recupero	Miglioramento clinico e superamento delle soglie (PHQ-9, GAD-7)
Ritorno sociale	Valore sociale generato per euro investito (SROI)
Equità territoriale	Esito e accesso tra Agenzie e tra aree metropolitane e alpine
Liste di attesa	Riduzione dei tempi di attesa e completamento della rete territoriale
Indicatori di sistema	Esito, esperienza, costo e operatori (Quadruple Aim)

Tabella L.3. Le dimensioni di sintesi del cruscotto regionale lombardo.

Definiti gli strumenti della misurazione, lo studio dispone di tutto l'occorrente per accertare nel tempo gli effetti della riforma. La Parte M ne ricompone i risultati in una valutazione multidimensionale e formula le raccomandazioni conclusive.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Griglia OCSE-DAC, analisi multi-criterio, sintesi del valore e raccomandazioni, limiti e agenda di ricerca

Sintesi conclusiva · caso strategico del Five Case Model · griglia di giudizio OCSE-DAC

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa è la parte conclusiva dello studio, e ha una funzione diversa da tutte le precedenti: non aggiunge una nuova analisi, ma ordina quelle già svolte in un giudizio. Lo strumento di questo giudizio è la griglia dei criteri dell'OCSE-DAC, che attraversa l'intero studio come metro di valutazione e converge qui nella sintesi; la parte fornisce inoltre il contenuto del caso strategico del Five Case Model.^{[567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582]} Le precedenti cornici del telaio dicono che cosa valutare, come decidere e come riportare l'economia; mancava la griglia rispetto alla quale l'intervento è infine giudicato, e la parte la applica (capitolo M.1), la integra con l'analisi multi-criterio per i criteri non monetari (M.2), ne ricava una sintesi del valore e raccomandazioni per il decisore (M.3) e ne dichiara, con franchezza, i limiti e l'agenda di ricerca (M.4).

M.1 La griglia di valutazione OCSE-DAC

I criteri dell'OCSE-DAC sono sei lenti complementari che, insieme, danno un quadro complessivo dell'intervento e dei suoi risultati: la rilevanza rispetto al bisogno, la coerenza con le altre politiche, l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse, l'impatto più ampio e la sostenibilità nel tempo.^[583] Essi operano in due momenti dello studio: ex ante orientano la valutazione complessiva, poiché ciascun

criterio diventa una domanda a cui le parti analitiche forniscono la risposta; ex post strutturano la verifica dei risultati, già trattata nella Parte L. La griglia, in tal modo, non si sovrappone all'analisi economica o ai domini della valutazione di tecnologia sanitaria, ma li ordina in un giudizio.

Applicata a questo studio, la griglia restituisce un giudizio convergente, con una sola qualificazione, propria del caso lombardo, sul criterio dell'efficienza. L'intervento è rilevante, perché risponde a un bisogno reale e di grande dimensione e all'obbligo di garantire i livelli essenziali;^[584] è coerente, perché compatibile con gli standard dell'assistenza territoriale, con il PNRR e con la legge regionale, ed è costituzionalmente difendibile, senza incontrare il vincolo del piano di rientro;^[585] è efficace, perché l'evidenza internazionale ne documenta il raggiungimento degli obiettivi clinici;^[586] è efficiente in termini di costo-utilità, con dominanza per paziente, pur a fronte di un saldo diretto negativo sul solo bilancio, di entità modesta;^[587] ha un impatto distributivo favorevole e un ritorno complessivo di 3,8-5,4 a uno;^[588] ed è sostenibile, sul piano finanziario e organizzativo.^[589] La tabella seguente riepiloga il giudizio, criterio per criterio.

Criterio	Domanda valutativa	Giudizio dallo studio
Rilevanza	Risponde al bisogno reale?	Sì: ~2.000.000 con disagio inevaso; obbligo dei livelli essenziali
Coerenza	È compatibile con le altre politiche?	Sì: DM 77, PNRR, L.R. 22/2021; difendibile in Costituzione; nessun rientro
Efficacia	Raggiunge gli obiettivi?	Sì: evidenza internazionale (recupero ~50%)
Efficienza	Impiega le risorse in modo proporzionato?	Sì in costo-utilità (dominanza); saldo diretto negativo a costo modesto
Impatto	Produce effetti più ampi?	Sì: riduce il gradiente territoriale; ritorno complessivo 3,8-5,4:1
Sostenibilità	I benefici e il servizio durano?	Sì: costo modesto, bilancio in equilibrio, istituzionalizzazione

Tabella M.1. La griglia di giudizio OCSE-DAC applicata allo studio, criterio per criterio.

M.2 L'analisi multi-criterio

L'analisi costo-efficacia e l'analisi del ritorno sociale esprimono il valore in termini prevalentemente monetari. La decisione pubblica, tuttavia, contempera una pluralità di criteri, alcuni dei quali non riducibili a denaro: l'equità, la fattibilità, la coerenza con gli indirizzi strategici, la solidità dell'evidenza. L'analisi multi-criterio rende esplicito questo bilanciamento, attribuendo a ciascun criterio un peso e a ciascuna opzione un punteggio, e aggregandoli in un punteggio complessivo.^[590] È il metodo che impedisce alla decisione di ridursi alla sola dimensione economica, e che al tempo stesso ne rende trasparente la logica, poiché i pesi e i punteggi sono dichiarati e sindacabili.

Il confronto è condotto tra l'opzione di intervento e l'opzione zero — il mantenimento dello status quo — su otto criteri pesati. Il risultato è netto: l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 80,7 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri a eccezione della sola fattibilità immediata, nella quale l'opzione zero — che non richiede alcuna attuazione — è ovviamente superiore, ma il cui svantaggio è gestito attraverso il dispiegamento graduale.^[591] Rispetto al caso pugliese, il punteggio

dell'intervento è lievemente inferiore, in ragione del saldo diretto negativo che riduce il sub-punteggio dell'impatto di bilancio; resta nondimeno una preferenza netta e stabile rispetto ai pesi adottati. La tabella seguente riporta la matrice delle prestazioni.

Criterio	Peso	Interv.	Opz. zero	Δ pond.
Efficacia clinica	15%	80	30	+7,5
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	88	25	+12,6
Impatto di bilancio e sostenibilità	15%	70	50	+3,0
Equità e accesso (aree alpine, liste di attesa)	15%	85	20	+9,75
Valore sociale	10%	88	20	+6,8
Fattibilità e implementabilità	10%	70	100	-3,0
Robustezza dell'evidenza	10%	75	60	+1,5
Coerenza strategica (DM 77, PNRR, L.R. 22/2021)	5%	90	25	+3,25
Punteggio complessivo ponderato	100%	80,7	39,25	+41,45

Tabella M.2. Analisi multi-criterio: confronto tra l'*****opzione di intervento e l'*****opzione zero su otto criteri pesati.

M.3 La sintesi del valore e le raccomandazioni

La sintesi del valore si lascia condensare in tre affermazioni, che costituiscono il cruscotto decisionale della riforma in Lombardia. La prima: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, dell'ordine di alcune decine di milioni, trascurabile rispetto a un finanziamento di ventuno miliardi. La seconda: il ritorno per la collettività è ampio, con un rapporto beneficio-costi dell'ordine di 3,8-5,4 a uno. La terza: il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali — la produttività, il funzionamento, il minor carico familiare — e non sul risparmio per il bilancio.^[592] È questa la corretta rappresentazione della proposta lombarda: non un investimento che si ripaga sui conti sanitari, ma un investimento sociale ad alto rendimento, il cui costo per il bilancio è trascurabile.

Da questa sintesi discende la raccomandazione centrale. La decisione rilevante non è se prevedere il servizio — già previsto dalla legge regionale del 2021, che ne ha tracciato la collocazione nelle Case della Comunità — ma se strutturarne e dimensionarlo, portandolo dalla previsione alla copertura del fabbisogno, dell'ordine di 2.190 incarichi.^[593] La sintesi del valore è letta, infine, lungo le cinque dimensioni del Quintuple Aim — l'esito di salute, l'esperienza della persona, il costo, il benessere degli operatori e l'equità — che ricompongono in un quadro unitario i risultati delle parti analitiche.^[594] La raccomandazione operativa è di procedere per gradi, secondo il dispiegamento scaglionato, avviando contestualmente la rilevazione e la valutazione controfattuale, in modo che ogni fase di estensione sia informata dai risultati della precedente.

M.4 I limiti e l'agenda di ricerca

La credibilità di una valutazione si misura anche dalla franchezza con cui ne dichiara i limiti. Il limite principale di questo studio è il radicamento nei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione lombarda, pari al 17,0%, e non estratte dai conti regionali certificati. È una distinzione che lo studio dichiara apertamente, perché la sostituzione di tali ricostruzioni con i valori certificati delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali è la condizione per la presentazione della proposta agli organi di controllo.^[595] A esso si aggiungono cautele di trasferibilità e di fonte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la cifra del ritorno è inoltre prudenziale e non ponderata per l'equità, e potrebbe perciò risultare conservativa.^[596]

Da questi limiti discende l'agenda di ricerca. L'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, seguito dall'avvio della rilevazione di servizio e dalla valutazione controfattuale sul dispiegamento scaglionato tra le otto Agenzie.^[597] È il programma che trasforma progressivamente la proposta argomentata in politica validata, e che salda la valutazione ex ante alla verifica ex post. Con questa parte si chiude lo studio regionale lombardo, che applica al contesto della Lombardia, con piena fedeltà metodologica e con le dovute qualificazioni di onestà, il medesimo telaio integrato già adottato per la Puglia: un intervento clinicamente fondato, economicamente sostenibile, equo e attuabile, il cui valore per la collettività è ampio e il cui costo per il bilancio è trascurabile.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LOMBARDIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base» nella cornice della L.R. 22/2021

Appendici A-E

Materiali di supporto allo studio regionale

Caso di riferimento e parametri, strumenti di esito e dataset, dati regionali e fonti, checklist di reporting, glossario

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

Questa appendice raccoglie il caso di riferimento comune all'intero studio, i parametri del modello di Markov e il quadro economico consolidato, perché le scelte metodologiche siano consultabili in un unico luogo e riproducibili.^{[598][599][600][601][602][603][604][605][606]} La tabella seguente espone gli elementi del caso di riferimento.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Servizio attuale o assenza del servizio a regime
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Agenzia/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudentiale	Riduzione per l'ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, indipendenti dalla regione, sono riepilogati di seguito.^[607]

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato per la Lombardia, ripreso dalla Parte E, è riportato per scenario nella tabella conclusiva dell'appendice.^[608]

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 1.100	~ 1.700	~ 2.190
Costo del servizio	~ 60	~ 95	~ 120
Risparmi diretti (SSR)	~ 35	~ 60	~ 90
Ricadute economico-sociali	~ 190	~ 360	~ 560
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -25	~ -35	~ -30
Saldo complessivo (caso economico)	+165	+325	+530
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,8:1	~4,4:1	~5,4:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

Questa appendice documenta gli strumenti di esito impiegati e il dataset minimo del protocollo di rilevazione, perché la misurazione sia trasparente e replicabile. Gli strumenti sono validati e di uso internazionale, e sono impiegati nei soli punteggi complessivi.^[609] La tabella seguente ne riepiloga le caratteristiche.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo elenca i campi del protocollo, con il momento di rilevazione, e costituisce il dizionario dei dati del sistema informativo.^[610]

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

Questa appendice raccoglie i valori regionali di ancoraggio impiegati nello studio e, soprattutto, esplicita la lacuna principale del lavoro, perché il lettore distingua con chiarezza ciò che è ricostruito da ciò che è certificato.^[611] La tabella seguente riporta i valori di ancoraggio per la Lombardia.

Ambito	Valore regionale
Popolazione regionale	10.033.918 abitanti (Censimento ISTAT 2024); la più popolosa d'Italia
Finanziamento del SSR	~ 21 miliardi di euro; conti in equilibrio; nessun piano di rientro
Mobilità sanitaria	Saldo attivo, dell'ordine di +580 milioni; regione creditrice e primo polo attrattivo
Pronto soccorso	~ 3 milioni di accessi/anno; quota inappropriata inferiore alle regioni a rete debole
Farmaceutica	Consumo dell'ordine di 900-950 DDD/1000 ab. die
Salute mentale	~ 2.000.000 con disagio comune; ~ 150.000 in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale
Funzione attuale (L.R. 22/2021)	Psicologi previsti nelle Case della Comunità; funzione non ancora strutturata; ~ 0% del fabbisogno

Tabella C.1. I valori regionali di ancoraggio della Lombardia.

La distinzione tra ricostruzione e certificazione è la vulnerabilità metodologica più rilevante dello studio, e va dichiarata senza attenuazioni: i valori economici sono in parte scalati per la quota di popolazione lombarda, pari al 17,0%, e non estratti dai conti regionali certificati.^[612] La tabella seguente elenca i dati certificati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Agenzia e per area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

Questa appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno riferito alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[613] La tabella seguente ne riepiloga l'applicazione.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

Questa appendice raccoglie le definizioni dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni allo studio pugliese, di cui questo lavoro replica il telaio metodologico.^[614]

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra trattati e non trattati
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità non trattate
Dispiegamento scaglionato	Attivazione progressiva che rende le aree non ancora coperte gruppo di confronto

Termine	Definizione
Analisi e verifica d’impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta a riferire al Consiglio sui risultati della riforma
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell’implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall’impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d’ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l’intensità dell’intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; in Lombardia il saldo è attivo
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di concentrazione	Misura che lega l’esito di salute alla posizione socio-economica
Peso morto	Quota dell’esito che si sarebbe verificata anche senza l’intervento

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

Con queste appendici si completano i materiali di supporto dello studio regionale lombardo, che applica al contesto della Lombardia, con piena fedeltà metodologica e con le dovute qualificazioni di onestà, il medesimo telaio integrato già adottato per la Puglia.

Trentino-Alto Adige — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sulla riforma «Psicologo di Base». Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell'intero corpus: la premessa, l'indice generale di tutte le parti e di tutte le appendici, la mappa di integrazione delle cornici metodologiche e la sintesi del valore. Il Trentino-Alto Adige occupa, nel panorama nazionale, una posizione propria e unica: è un territorio ripartito in due Province autonome — Trento e Bolzano — ciascuna titolare di un proprio Servizio sanitario e già dotata di forme di psicologia territoriale: il Trentino con una convenzione fra l'APSS e studi psicologici privati (legge provinciale del 2016, con ticket), l'Alto Adige con un Servizio psicologico territoriale pubblico e bilingue (Sabes). Proprio per questo la decisione rilevante non è se istituire il servizio, già presente in forme diverse, ma strutturarlo in un modello pieno di psicologo di base e armonizzarne gli assetti fra le due Province, dimensionandolo verso la copertura piena del fabbisogno, in un territorio fra i più giovani, ricchi e sani d'Italia, a piena autonomia finanziaria e in avanzo di bilancio.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell'intero corpus, che può essere percorso nell'ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, verifica empirica, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, cronoprogramma, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, controfattuale su strutturazione progressiva, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazioni, condizioni, conclusione
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati del territorio e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — negativo ma modesto e agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo di bilancio delle due Province, più sfavorevole che nelle regioni sotto-finanziate proprio perché il sistema, già ben dotato ed efficiente, lascia minori margini di recupero diretto, con un saldo di mobilità trascurabile poiché le due Province attraggono pazienti — e il saldo complessivo, ampiamente positivo. La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 7	~ 11	~ 14
Risparmi diretti (SSR)	~ 4	~ 7	~ 10
Ricadute economico-sociali	~ 25	~ 48	~ 67
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -3	~ -4	~ -4
Saldo complessivo (caso economico)	+22	+44	+63
Rapporto beneficio-costo complessivo	~4,1:1	~5,0:1	~5,5:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante, per il Trentino-Alto Adige, è strutturare in un modello pieno di psicologo di base gli assetti già operanti nelle due Province e armonizzarli fra i due ordinamenti provinciali, dimensionandolo per gradi verso la copertura sistematica, dell'ordine di 120 psicologi nello scenario conservativo, 180 in quello di base e 240 in quello espansivo. Il limite principale è il radicamento dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione, dell'1,8%, e non estratte dai conti provinciali certificati delle due aziende sanitarie provinciali; il territorio dispone tuttavia, grazie agli assetti già operanti, di una base di dati propri più solida di quella delle regioni che partono da zero, da consolidare in forma comparabile e interoperabile fra le due Province come condizione per la presentazione agli organi di controllo.

Lo studio si fonda, sul piano comparativo, sui programmi internazionali più autorevoli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie — il programma inglese di terapie psicologiche, il modello olandese, l'iniziativa australiana e il Collaborative Care statunitense — dei quali mutua le evidenze di efficacia e di costo-efficacia, adattandole con cautela al contesto del Trentino-Alto Adige. La condizione propria del territorio — due Province autonome dotate di assetti di psicologia territoriale già operanti — consente di fondare la valutazione controfattuale sulla strutturazione progressiva del modello pieno, come un esperimento a cunei progressivi tra i comprensori e i distretti delle due Province, con il vantaggio di una base informativa più ricca di quella delle regioni che partono da zero. Su questa base, e con la dichiarazione trasparente dei propri limiti, il corpus consegna al decisore un quadro completo e onesto su cui deliberare, e a un territorio che dispone già del servizio in forme diverse l'occasione di dargli una forma compiuta e omogenea.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell'HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per il Trentino-Alto Adige, che applica al territorio il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria, al Lazio, alla Campania, alla Sicilia e alla Sardegna. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati al Trentino-Alto Adige.

Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). Il Trentino-Alto Adige occupa nella serie una posizione propria e unica: il territorio è ripartito in due Province autonome, Trento e Bolzano, ciascuna titolare di un proprio Servizio sanitario e di forme di psicologia territoriale già operanti, sicché la valutazione non riguarda l'opportunità di introdurre il servizio, ma la sua strutturazione in un modello pieno e la sua armonizzazione fra i due sistemi sanitari autonomi.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il servizio di psicologia delle cure primarie del Trentino-Alto Adige, inteso come strutturazione in un modello pieno di psicologo di base e armonizzazione di funzioni che le due Province autonome esercitano già in forme diverse — il modello trentino di convenzione con studi privati e il Servizio psicologico territoriale dell'Alto Adige.^[615] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sulla consolidazione e l'estensione del servizio. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante, per il Trentino-Alto Adige, non è istituire il servizio, già presente in forme diverse, ma strutturarlo in un modello pieno di psicologo di base, armonizzarne gli assetti fra le due Province e dimensionarlo verso la copertura sistematica del fabbisogno, entro un contesto di piena autonomia finanziaria e di avanzo di bilancio che rende la spesa agevolmente sostenibile. Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala. Va segnalato sin d'ora che gli assetti attuali delle due Province, pur già operanti, restano al di sotto dello stesso scenario conservativo qui considerato, che rappresenta invece il modello pieno verso la copertura sistematica.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 217.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai servizi, in un quadro segnato da componenti convergenti — il disagio giovanile, prevalente in una popolazione fra le più giovani d'Italia, il bisogno connesso al lavoro e allo stress in un'economia a pieno impiego, e la domanda dell'età anziana, contenuta da indicatori di salute fra i migliori del Paese — cui si aggiungono i divari di accesso delle valli alpine a popolazione dispersa e, in modo strutturale, la necessità di erogare il servizio nelle diverse lingue del territorio, tedesco, italiano e ladino. La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti del Trentino-Alto Adige con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è il servizio di psicologia delle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, condotto dalla forma attuale alla strutturazione piena e armonizzata. Il confronto è la condizione attuale, nella quale operano il modello trentino di convenzione e il Servizio psicologico dell'Alto Adige, distinti e non

armonizzati. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l’orizzonte pluriennale degli esiti dall’orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è dato dai due Servizi sanitari provinciali — l’APSS del Trentino e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (Sabes) — e dalla rete delle Case della Comunità in costruzione. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per il Trentino-Alto Adige
Popolazione	Residenti del Trentino-Alto Adige con disagio psichico comune (~217.000); in seconda istanza l’intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Modello pieno di psicologo di base, armonizzato fra le due Province, primo livello e filtro (~120/180/240 psicologi); dalle forme attuali alla copertura sistematica
Confronto	Condizione attuale: modello trentino di convenzione con studi privati (legge 2016) e Servizio psicologico territoriale dell’Alto Adige, distinti e non armonizzati
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Due Servizi sanitari provinciali autonomi: APSS (Trentino) e Azienda Sanitaria dell’Alto Adige - Sabes; rete delle Case della Comunità in costruzione; plurilinguismo (tedesco, italiano, ladino)

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell’HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell’OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l’intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l’insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e gli assetti esistenti delle due Province come comparatore. Le unità di analisi sono il territorio regionale e, in disaggregazione, le due Province autonome, i comprensori sanitari e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni, segnatamente fra i centri urbani e le valli alpine a popolazione dispersa, e della dimensione linguistica.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale: modello trentino di convenzione con studi privati e Servizio psicologico territoriale dell'Alto Adige, distinti e non armonizzati
Unità di analisi	Territorio regionale, con disaggregazione per Provincia autonoma, comprensorio sanitario e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. Tale prudenza assume, per il Trentino-Alto Adige, un rilievo particolare ma di segno opposto a quello delle regioni sotto-finanziate. Entrambe le Province autonome finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto sul proprio territorio, senza apporto a carico del Bilancio dello Stato, e operano in avanzo, con la spesa sanitaria pro-capite più elevata d'Italia. Il vincolo non è la scarsità di risorse, ma il suo rovescio: poiché il sistema è già ampiamente finanziato ed efficiente, il margine di consumo improprio recuperabile è più contenuto, e il costo unitario del personale è fra i più alti del Paese; sul versante della mobilità, il saldo passivo è modesto e le due Province attraggono pazienti più di quanti ne perdano, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento trascurabile. Ne consegue un saldo diretto negativo — più sfavorevole che nelle regioni sotto-finanziate, proprio perché il sistema lascia minori margini di recupero — ma di entità modesta e agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo, e il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi. Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti provinciali certificati; le due Province dispongono tuttavia, grazie agli assetti già operanti, di una base di dati propri più solida di quella delle regioni che partono da zero, da consolidare come fonte primaria.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post. Per il Trentino-Alto Adige il disegno controfattuale assume una forma propria: poiché la strutturazione del modello pieno avverrà in tempi differenziati fra i comprensori e i distretti delle due Province, esso può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, con l'ordine e i tempi di attivazione fra i territori impiegati a fini valutativi e

l'effetto causale stimato dai metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico, calibrati sui dati già disponibili dal modello trentino e dal Servizio dell'Alto Adige. La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce le due Province autonome di Trento e Bolzano, i rispettivi Assessorati alla salute, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) del Trentino e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (Sabes), l'Ordine degli Psicologi della Regione Trentino-Alto Adige, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei dell'Università di Trento e della Libera Università di Bolzano. La caratteristica propria del Trentino-Alto Adige è che la materia sanitaria è di competenza provinciale, non regionale, e che i due Servizi sanitari sono distinti e autonomi. Poiché il servizio è già presente in forme diverse e la rete delle Case della Comunità è in costruzione, la sfida del governo non è istituire il servizio, né dispiegarlo entro un'unica azienda, ma strutturarlo in un modello pieno e garantirne l'armonizzazione fra due sistemi sanitari pienamente autonomi e fra le diverse lingue del territorio: è il tratto che distingue il Trentino-Alto Adige, e che la valutazione assume come punto di partenza.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza, con la piattaforma informativa sanitaria regionale quale infrastruttura per la raccolta uniforme. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di

rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto del Trentino-Alto Adige.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Quadro demografico, epidemiologia del bisogno, domanda e offerta, disuguaglianze, servizi e flussi, cornice normativa

Primo dominio dell'HTA · il problema di salute e il bisogno

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto del Trentino-Alto Adige. La struttura è quella già adottata per le altre regioni della serie, e mutano soltanto i dati, ancorati al territorio. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall'epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l'intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico del Trentino-Alto Adige: non un servizio da istituire, ma un servizio già presente in forme diverse nelle due Province autonome — il modello trentino di convenzione e il Servizio psicologico dell'Alto Adige — da strutturare in un modello pieno e armonizzare, in un territorio fra i più giovani, ricchi e sani d'Italia, a piena autonomia finanziaria, in avanzo di bilancio e plurilingue.

B.1 Quadro demografico

Il Trentino-Alto Adige conta circa 1.085.000 residenti, pari a circa l'1,8% della popolazione nazionale, ripartiti quasi equamente fra le due Province autonome — 545.169 in Trentino e 539.386 in Alto Adige — e, a differenza della maggior parte delle regioni, in crescita, per effetto di una natalità fra le più elevate d'Italia e di saldi migratori positivi. La struttura per età è fra le più giovani del Paese, con una speranza di vita fra le più alte e indicatori di salute fra i migliori d'Italia; la provincia di Bolzano è leggermente più giovane di quella di Trento. Il tratto distintivo è la composizione linguistica dell'Alto Adige — 68,61% gruppo tedesco, 26,98% italiano, 4,41% ladino — con tutela costituzionale e proporzionale etnica. La popolazione si addensa nei centri urbani di Trento, Bolzano e Merano, mentre una quota rilevante risiede nelle valli alpine in comuni di piccola dimensione. La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per il Trentino-Alto Adige
Popolazione (2024)	~1.085.000 (~1,8% del totale nazionale); Trentino 545.169, Alto Adige 539.386; in crescita per natalità elevata e saldi migratori positivi
Età e salute	Fra le regioni più giovani d'Italia; speranza di vita fra le più alte (Trentino +6,7 anni sulla media); Bolzano più giovane per natalità superiore
Composizione linguistica	Alto Adige: 68,61% tedesco, 26,98% italiano, 4,41% ladino (Censimento 2024); Trentino italofono con minoranze ladine, mochene, cimbre; stranieri ~9-10%
Distribuzione territoriale	Due Province di dimensione simile; centri urbani di Trento, Bolzano, Merano; quota rilevante nelle valli alpine in piccoli comuni
Profilo territoriale	Centri urbani con servizi concentrati; valli alpine a popolazione dispersa con accesso più oneroso; sovrapposizione dell'asse linguistico in Alto Adige
Articolazione sanitaria	Due Servizi sanitari provinciali autonomi: APSS (Trentino) e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige - Sabes; competenza sanitaria provinciale, non regionale

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico del Trentino-Alto Adige.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale nel Trentino-Alto Adige è ampio e sospinto da una struttura demografica fra le più giovani d'Italia, distribuita su un territorio montano. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell'ordine di 217.000 persone, in parte già raggiunte dagli assetti esistenti, ma non ancora coperte in un modello pieno e armonizzato. A questa quota si somma un'utenza specialistica in carico ai servizi, su un territorio che presenta una specificità propria: entrambe le Province dispongono già di forme di psicologia territoriale, il modello trentino di convenzione e il Servizio psicologico dell'Alto Adige. Tre componenti orientano la domanda. La prima e più caratterizzante è il disagio giovanile, accentuato dalla pressione scolastica e prestazionale in una popolazione molto giovane. La seconda è il bisogno connesso al lavoro e allo stress in un'economia a pieno impiego, e quello dell'età anziana, contenuto da indicatori di salute fra i migliori del Paese. La terza è il disagio connesso all'isolamento nelle valli alpine a popolazione dispersa. È la combinazione — due Province autonome con sistemi distinti, popolazione giovane e ricca, plurilinguismo e avanzo di bilancio — a distinguere il fabbisogno del Trentino-Alto Adige. La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche resi più onerosi dalle distanze nelle valli.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappongono, nel Trentino-Alto Adige, assetti già operanti ma distinti: il Trentino dispone dal 2016 di un modello di convenzione fra l'APSS e studi psicologici privati — prima esperienza in Italia — che eroga cicli di sedute in sei ambiti definiti, su invio dell'Azienda e con ticket; l'Alto Adige dispone di un Servizio psicologico territoriale pubblico e bilingue nell'ambito del proprio Servizio sanitario. Il fabbisogno a regime è stimato nell'ordine di 240 psicologi nello scenario espansivo, e l'Ordine professionale regionale ne sostiene la strutturazione in un modello pieno e l'armonizzazione. La copertura attuale corrisponde

dunque a forme parziali e non armonizzate: non un servizio da istituire, ma un servizio da strutturare in un modello pieno, armonizzare fra le due Province e dimensionare. La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per il Trentino-Alto Adige
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 217.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	Ampia (alcune decine di migliaia, stima rapportata ai dati nazionali)
Offerta territoriale attuale	Trentino: convenzione APSS-studi privati (legge 2016), sei ambiti, cicli 8-16 sedute, con ticket; Alto Adige: Servizio psicologico territoriale pubblico e bilingue (Sabes)
Fabbisogno stimato a regime	~ 240 psicologi nello scenario espansivo (120-180 negli altri scenari)
Copertura attuale del fabbisogno	Forme parziali e non armonizzate nelle due Province; non ancora strutturate in un modello pieno

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, nel Trentino-Alto Adige, si gioca su due assi. Il primo, territoriale, separa i centri urbani di Trento, Bolzano e Merano dalle valli alpine a popolazione dispersa, penalizzate dalle distanze e dall'orografia. Il secondo, distintivo, è linguistico: l'accesso effettivo richiede che il servizio sia disponibile nella lingua del residente — tedesco, italiano o ladino — secondo la tutela costituzionale dei gruppi. Su questi divari il modello pieno agisce in funzione di equità: avvicina l'offerta alle valli mediante la telepsicologia assistita e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica; la disponibilità di personale plurilingue è condizione di equità effettiva, e l'armonizzazione degli assetti fra le due Province assicura parità di accesso a residenti di entrambi i territori.

B.5 I servizi e i flussi

I due Servizi sanitari provinciali dispongono della spesa pro-capite più elevata d'Italia; entrambe le Province autonome finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto, senza apporto a carico del Bilancio dello Stato, e operano in avanzo. Il sistema, già ampiamente finanziato, lascia margini di consumo improprio più contenuti da recuperare, e il costo unitario del personale è fra i più alti del Paese. Il profilo di mobilità è modesto e per alcune branche attivo, poiché le due Province attraggono pazienti; il canale del recupero della mobilità è per questo intervento trascurabile. L'architettura dei servizi poggia su due aziende sanitarie provinciali autonome — l'APSS del Trentino e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (Sabes) — articolate in comprensori e distretti, e su una rete di Case della Comunità in costruzione, su cui il modello pieno andrà innestato e armonizzato. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per il Trentino-Alto Adige
Finanziamento dei Servizi sanitari provinciali	Autofinanziamento integrale con i 9/10 del gettito trattenuto, senza apporto statale; spesa pro-capite la più alta d'Italia; bilanci in avanzo; costo del personale fra i più alti
Mobilità sanitaria	Saldo modesto e per alcune branche attivo (le Province attraggono pazienti); canale del recupero trascurabile per questo intervento
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche contenuti da cure primarie ben dotate; resi più onerosi dalle distanze nelle valli
Architettura dei servizi	Due aziende sanitarie provinciali autonome (APSS Trentino; Sabes Alto Adige), articolate in comprensori e distretti; rete delle Case della Comunità in costruzione
Margine di azione principale	Strutturazione in un modello pieno e armonizzazione fra le due Province, accesso nelle valli alpine, plurilinguismo, disagio giovanile, intercettazione precoce

Tabella B.3. I servizi e i flussi dei Servizi sanitari provinciali rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice particolare, in cui la competenza sanitaria è provinciale e i due assetti poggiano su ordinamenti distinti: il modello trentino di convenzione, introdotto da una legge provinciale del 2016, e il Servizio psicologico territoriale dell'Alto Adige. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera; sul piano provinciale opera entro una piena autonomia finanziaria e un avanzo di bilancio. La decisione rilevante, in questo contesto, non è istituire una funzione, già presente in forme diverse, ma strutturarla in un modello pieno, armonizzarla fra le due Province e dimensionarla: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte C

L'intervento e il suo modello

Definizione e teoria del cambiamento, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali, formazione

Secondo e terzo dominio dell'HTA · l'intervento e la sua descrizione

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico del

Trentino-Alto Adige emerge con nettezza: l'intervento non è da istituire, ma da strutturare in un modello pieno a partire da assetti già operanti in entrambe le Province autonome — il modello trentino di convenzione e il Servizio psicologico dell'Alto Adige — di cui occorre comporre e armonizzare il modello, il sistema informativo e il monitoraggio, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna Provincia e del plurilinguismo.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire; nel Trentino-Alto Adige tale funzione è già esercitata in forme diverse dalle due Province e si tratta di strutturarla in un modello pieno e di armonizzarla. La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria. Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell'ordine di 217.000 persone con disagio comune. La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per il Trentino-Alto Adige
Bisogno	~ 217.000 persone con disagio comune, in parte già raggiunto dagli assetti esistenti
Attività	Modello pieno di psicologo di base armonizzato fra le due Province: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo delle cure primarie nelle Case della Comunità e nei distretti, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i servizi di salute mentale. Il punto di partenza è dato dai due assetti provinciali esistenti: in Trentino il modello di convenzione fra l'APSS e studi psicologici privati (legge del 2016), con cicli di sedute su invio dell'Azienda e con ticket; in Alto Adige il Servizio psicologico territoriale pubblico, bilingue e organizzato per comprensori. La strutturazione in un modello pieno e l'armonizzazione fra i due assetti — in un territorio ripartito in due Province autonome con Servizi sanitari distinti, e con l'esigenza di erogare il servizio in tedesco, italiano e ladino — sono la sfida organizzativa principale, da affrontare nel rispetto dell'autonomia di ciascuna Provincia. La rete territoriale delle Case della Comunità, in costruzione, è l'infrastruttura su cui il servizio andrà pienamente innestato. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, una valutazione iniziale con progetto clinico individuale, un ciclo di colloqui brevi con programma di sostegno personalizzato e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti; esso è da strutturare in forma piena e armonizzata fra le due Province a partire dagli assetti già operanti, e affronta i quadri più frequenti, dalla sintomatologia ansioso-depressiva ai problemi di adattamento e psicosomatici. Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata. Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con la piattaforma informativa sanitaria regionale e con il fascicolo sanitario elettronico, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. Il coordinamento informativo deve raccordare i sistemi delle due aziende sanitarie provinciali — l'APSS e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige — e garantire l'interoperabilità e l'uniformità della rilevazione fra i due territori. La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale; poiché il servizio è presente in forme diverse, il Trentino-Alto Adige può impostare il flusso in forma uniforme e interoperabile fra le due Province, valorizzando i dati già disponibili dal modello trentino e dal Servizio dell'Alto Adige.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale. Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile. L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica. La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, nel Trentino-Alto Adige, lo strumento per garantire l'accesso nelle valli alpine a popolazione dispersa e, in un contesto plurilingue, per mettere a disposizione anche a distanza personale della

lingua del paziente, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza. I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici. La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle valli alpine disperse; disponibilità di personale plurilingue a distanza	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso l'Università di Trento e la Libera Università di Bolzano; il livello post-universitario specialistico attraverso una formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, comprensiva della competenza per il disagio giovanile, prioritario in una delle regioni più giovani d'Italia, e delle competenze linguistiche per l'erogazione in tedesco, italiano e ladino; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione. A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità, sostenuta dalla piattaforma informativa sanitaria regionale. Il Trentino-Alto Adige presenta qui un elemento di metodo: l'esperienza trentina di convenzione, attiva dal 2016, e il Servizio psicologico dell'Alto Adige costituiscono una base operativa su cui innestare il percorso formativo del modello pieno. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Università di Trento e Libera Università di Bolzano
2. Post-universitario specialistico	Psicologia delle cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, disagio giovanile e competenze linguistiche (tedesco, italiano, ladino)	Base nei due assetti provinciali esistenti
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte D

Efficacia clinica ed evidenza

Metodo della revisione, evidenza di efficacia, qualità GRADE, benchmark internazionali, trasferibilità

Quarto dominio dell'HTA · l'efficacia clinica

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte affronta il quarto dominio della valutazione, l'efficacia clinica, e ne ricostruisce la base di evidenza. Come per le regioni precedenti, il corpo dell'evidenza internazionale è invariante, poiché l'efficacia di un intervento clinico non muta con i confini regionali; muta invece la base di evidenza locale, ed è qui che il Trentino-Alto Adige presenta un tratto proprio. La parte espone il metodo della revisione e i risultati di efficacia (capitolo D.1); ne gradua la qualità e ne dichiara una cautela economica essenziale (D.2); presenta i benchmark internazionali (D.3); e discute le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale del Trentino-Alto Adige (D.4). Quest'ultima presenta una condizione propria: grazie agli assetti già operanti nelle due Province, il Trentino-Alto Adige dispone di una base di dati di esito propri più estesa che altrove, sicché lo studio si fonda, per l'efficacia, sui benchmark internazionali e li affina con i dati del modello trentino e del Servizio dell'Alto Adige, consolidando l'evidenza locale con la strutturazione del modello pieno.

D.1 Il metodo della revisione e l'evidenza di efficacia

La sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale, con preferenza per le fonti più recenti. Il nucleo dell'evidenza proviene

dal modello della cura collaborativa, di cui lo studio fondativo ha documentato che circa la metà dei pazienti trattati conseguiva una riduzione sostanziale dei sintomi a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura usuale. La robustezza del risultato è confermata dalla meta-analisi su cinquantasette studi controllati, con un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a poco meno di un terzo di deviazione standard, e da una più recente revisione di quarantadue implementazioni, che documenta riduzioni rilevanti della depressione e dell’ansia e una contrazione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri. Sul versante dei dati reali, il programma inglese delle terapie psicologiche registra, su scala di oltre un milione di persone l’anno, un tasso di recupero del 50,2% e un miglioramento affidabile di oltre due terzi, con completezza dei dati di esito superiore al 98%. Anche le sintesi più caute confermano un effetto di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante sull’intera popolazione.

D.2 La qualità dell’evidenza e una cautela economica

La graduazione della certezza secondo il sistema GRADE colloca l’efficacia clinica dell’integrazione psicologica nelle cure primarie su un livello da moderato a elevato per i disturbi comuni, mentre la certezza è più eterogenea e minore per gli esiti economici, in particolare per quelli di sistema. Da questa graduazione discende una cautela che lo studio adotta come principio di onestà intellettuale, e che merita di essere enunciata senza attenuazioni: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l’intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero. Ciò significa che il valore economico del modello non può essere fondato sui risparmi sanitari diretti, ma poggia in misura preponderante sui ritorni sociali. È una cautela che, lungi dall’indebolire il caso del Trentino-Alto Adige, ne corrobora la coerenza interna, poiché il caso economico del Trentino-Alto Adige — come si vedrà nella Parte E — è fondato anch’esso sulle ricadute sociali, e non su un risparmio diretto che il territorio non potrebbe rivendicare con certezza statistica, tanto più in un sistema già ampiamente finanziato in cui i margini di recupero diretto sono contenuti.

D.3 I benchmark internazionali

L’evidenza si concretizza in quattro programmi nazionali consolidati, che costituiscono i riferimenti per il disegno del servizio. Il programma inglese delle terapie psicologiche è il riferimento principale per l’organizzazione: servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell’ordine del 50% e monitoraggio degli esiti pressoché completo. Il modello olandese integra una figura di supporto psicologico nello studio del medico di base, adottata dalla maggioranza dei medici, con ruolo complementare alla specialistica. Il modello australiano, a invio esterno, ha innalzato di oltre dieci punti la quota di popolazione in trattamento. Il modello statunitense della cura collaborativa, validato da oltre novanta studi controllati, documenta riduzioni rilevanti della depressione e dei ricoveri. La tabella seguente ne riepiloga i tratti salienti.

Programma	Modello	Risultati principali
Regno Unito (NHS Talking Therapies)	Servizio integrato a intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio esiti >98%; >1,3 milioni/anno
Paesi Bassi (POH-GGZ)	Supporto psicologico nello studio del medico di base	Adozione da ~tre quarti dei medici; ruolo complementare
Australia (Better Access)	Invio esterno a professionisti	Popolazione in trattamento dal 35% al 46%
Stati Uniti (Collaborative Care)	Équipe integrata con monitoraggio	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione, -41% ricoveri

D.4 Le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale

Sul piano nazionale, il quadro comprende i servizi avviati nelle regioni dotate di legge — fra cui la Campania, prima a istituire e attivare il servizio — e le esperienze pilota fondate su campioni limitati. Il Trentino-Alto Adige, che dispone già in entrambe le Province di forme di psicologia territoriale, vi si colloca come territorio dotato di esperienza operativa propria più estesa che altrove. Più in generale, i risultati internazionali provengono da sistemi diversi per organizzazione e finanziamento, e la loro trasposizione richiede validazione locale, evitando di trasferire meccanicamente le stime, soprattutto quelle economiche. È qui che la posizione del Trentino-Alto Adige presenta una condizione propria, da dichiarare con franchezza: grazie agli assetti già operanti, l'evidenza locale poggia su una base operativa più solida che altrove, e si affina con i dati propri del modello trentino di convenzione e del Servizio psicologico dell'Alto Adige. La condizione del Trentino-Alto Adige è dunque di consolidare l'evidenza locale: il territorio dispone degli assetti già operanti, delle infrastrutture informatiche delle due aziende sanitarie provinciali e della rete delle Case della Comunità in costruzione, e può impostare una rilevazione uniforme e interoperabile fra le due Province, tenendo conto del contesto plurilingue, generando dati propri solidi man mano che il modello pieno si struttura a regime. Una precisazione di metodo, infine, accompagna l'intero studio a garanzia della sua credibilità. Alcune cifre di larga circolazione — il rapporto di quattro a uno, l'affermazione per cui un euro ne genererebbe dieci, il rapporto di due e mezzo a uno talvolta richiamato in sede regionale — sono semplificazioni divulgative. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, e lo studio adotta prudenzialmente un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,8 a 5,5 a uno. Su questa base di evidenza, graduata e dichiarata nei suoi limiti, poggia la valutazione economica della Parte E.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte E

Valutazione economica

Costo del servizio, risparmi diretti, ricadute sociali, saldo, costo-utilità e impatto sul bilancio

Quinto dominio dell'HTA · la valutazione economica

Parte E — Valutazione economica

Questa parte affronta il quinto dominio della valutazione, quello economico, e ne costituisce il cuore quantitativo. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i valori, ancorati al Trentino-Alto Adige. La parte definisce l'impianto e il costo del servizio (capitolo E.1); quantifica i risparmi diretti per il bilancio sanitario, canale per canale (E.2); stima le ricadute economico-sociali per la collettività (E.3); compone il quadro consolidato, con il saldo e il rapporto beneficio-costi, tenendo ferma la distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico (E.4); presenta l'analisi costo-utilità per paziente e la sua robustezza probabilistica (E.5); e valuta l'impatto sul bilancio e la sostenibilità (E.6). Per il Trentino-Alto Adige il risultato si lascia anticipare in una formula: il caso finanziario diretto è di disavanzo modesto, più ampio che nelle regioni sotto-finanziate ma agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo, il caso economico complessivo è fortemente positivo, e il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali.

E.1 L'impianto e il costo del servizio

La valutazione economica impiega congiuntamente tre strumenti complementari — l'analisi costo-utilità, l'analisi di impatto sul bilancio e l'analisi del ritorno sociale — nella doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, che distingue i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute più ampie. Il costo del servizio a regime, assumendo un costo medio annuo per psicologo dell'ordine di 60.000 euro comprensivo degli oneri — riferimento più elevato che nelle altre regioni, dato che il livello retributivo nel Trentino-Alto Adige è fra i più alti del Paese — è dell'ordine di 7 milioni di euro nello scenario conservativo, 11 milioni in quello di base e 14 milioni in quello espansivo. I tre scenari rappresentano gradi crescenti di copertura verso il fabbisogno pieno; va ribadito che gli assetti esistenti delle due Province costituiscono forme parziali inferiori al modello pieno qui considerato, e non il regime a copertura sistematica. La tabella seguente riepiloga il costo del servizio per scenario.

Scenario	Psicologi	Costo annuo	Quota del FSR
Conservativo	~ 120	~ 7 milioni	~ 0,3%
Base	~ 180	~ 11 milioni	~ 0,4%
Espansivo	~ 240	~ 14 milioni	~ 0,5%

Tabella E.1. Il costo del servizio a regime nei tre scenari di copertura.

E.2 I risparmi diretti per il bilancio sanitario

I risparmi diretti per il bilancio sanitario si articolano in quattro canali. Il primo è la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, dell'ordine di 1, 1 e 2 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Il secondo è la riduzione della spesa farmaceutica inappropriata, dell'ordine di 1, 2 e 2 milioni. Il terzo, il più consistente, è la riduzione di ricoveri evitabili e di specialistica impropria, dell'ordine di 2, 3 e 5 milioni; il margine di recupero è qui più contenuto che altrove, poiché il sistema è già ampiamente dotato ed efficiente e lascia meno consumo improprio da recuperare. Il quarto, il recupero della mobilità, è per il Trentino-Alto Adige trascurabile, dell'ordine di 0, 1 e 1 milione: il saldo di mobilità è modesto e per alcune branche attivo, poiché le due Province attraggono pazienti più di quanti ne perdano, sicché questo canale contribuisce solo marginalmente. La somma dei quattro canali è dell'ordine di 4, 7 e 10 milioni di euro l'anno, e determina, a fronte del costo del servizio, un saldo diretto negativo, dell'ordine di -3, -4 e -4 milioni: più sfavorevole che nelle regioni sotto-finanziate, proprio perché il sistema, già ben dotato, lascia minori margini di recupero diretto, ma di entità modesta e agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo di bilancio. La tabella seguente dettaglia i canali del risparmio diretto.

Canale (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Accessi impropri al pronto soccorso	~ 1	~ 1	~ 2
Spesa farmaceutica inappropriata	~ 1	~ 2	~ 2
Ricoveri evitabili e specialistica	~ 2	~ 3	~ 5
Recupero della mobilità (frazione territoriale)	~ 0	~ 1	~ 1
Totale risparmi diretti	~ 4	~ 7	~ 10
Costo del servizio	~ 7	~ 11	~ 14
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -3	~ -4	~ -4

Tabella E.2. I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale e il saldo diretto.

E.3 Le ricadute economico-sociali

Oltre i confini del bilancio sanitario, l'intervento genera ricadute economico-sociali ampie, di cui la valutazione tiene conto nella prospettiva societale. Esse comprendono il recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo — con peso particolare in un'economia ad alta attività, a pieno impiego e con redditi e produttività fra i più alti d'Europa, e nella componente giovanile, prevalente in una delle regioni più giovani d'Italia — oltre al valore del benessere recuperato e al minor carico assistenziale sulle famiglie, e sono stimate, secondo i criteri prudenziali dello studio, nell'ordine di 25, 48 e 67 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Sommate ai risparmi diretti, esse determinano un ritorno complessivo dell'ordine di 29, 55 e 77 milioni di euro l'anno, e un saldo complessivo per la collettività ampiamente positivo, dell'ordine di +22, +44 e +63 milioni. Ne discende un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 4,1 a uno nello scenario conservativo, 5,0 a uno in quello di base e 5,5 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale adottata.

E.4 Il quadro consolidato: caso finanziario e caso economico

La composizione delle grandezze impone di tenere ferma una distinzione che governa l'intera lettura del caso del Trentino-Alto Adige. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di disavanzo diretto, più ampio che nelle regioni sotto-finanziate perché il sistema, già ben dotato ed efficiente, lascia minori margini di recupero e il canale della mobilità è trascurabile; tale disavanzo resta tuttavia di entità modesta e agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo di bilancio delle due Province. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe: si tratta di un investimento sociale, a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto e pienamente compatibile con la solidità finanziaria del territorio. La tabella consolidata che segue è lo strumento sintetico per la decisione, e distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale.

Voce (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 7	~ 11	~ 14
Risparmi diretti (SSR)	~ 4	~ 7	~ 10
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -3	~ -4	~ -4
Ricadute economico-sociali	~ 25	~ 48	~ 67
Ritorno complessivo	~ 29	~ 55	~ 77
Saldo complessivo (caso economico)	~ +22	~ +44	~ +63
Rapporto beneficio-costo complessivo	~ 4,1:1	~ 5,0:1	~ 5,5:1

Tabella E.3. Il quadro economico consolidato, con la distinzione fra caso finanziario e caso economico.

E.5 L'analisi costo-utilità per paziente

Accanto alle grandezze aggregate, la valutazione conduce un'analisi costo-utilità per paziente trattato, mediante un modello di Markov a cinque anni con sconto del 3%, indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. Il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: a un tempo meno costoso e più efficace. L'analisi di sensibilità probabilistica, su diecimila simulazioni, conferma la solidità del risultato: l'intervento è costo-efficace nell'88,9% dei casi alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro. La tabella seguente riepiloga il risultato per paziente.

Grandezza (per paziente)	Comparatore	Intervento	Differenza
Costo atteso per paziente	~ 3.799 euro	~ 2.495 euro	- 1.304 euro
Anni di vita ponderati (QALY)	3,392	3,627	+ 0,236
Esito	—	—	Intervento dominante
Costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	—	—	88,9% delle simulazioni

Tabella E.4. L'analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni).

E.6 L'impatto sul bilancio, la sostenibilità e la lacuna dei dati

Sul piano dell'impatto sul bilancio, il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta della spesa sanitaria, dell'ordine dello 0,3% nello scenario conservativo e dello 0,5% in quello espansivo; la sostenibilità è qui il punto più favorevole della serie, poiché entrambe le Province autonome finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto, senza apporto a carico dello Stato, e operano in avanzo, con la spesa pro-capite più alta d'Italia. Il vincolo non è la scarsità di risorse: la strutturazione del modello pieno è

agevolmente finanziabile entro l'autonomia di bilancio di ciascuna Provincia, e la questione è di scelta allocativa e di coordinamento. Resta da dichiarare con franchezza la lacuna dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti certificati delle due aziende sanitarie provinciali; il Trentino-Alto Adige dispone tuttavia, grazie agli assetti già operanti, di una base di dati propri più solida di quella delle regioni che partono da zero, sicché la stima, fondata sui benchmark, può essere affinata con i dati del modello trentino e del Servizio dell'Alto Adige; l'estrazione dei dati certificati delle due Province resta la priorità da completare. La sintesi è univoca: il caso diretto è prudente e in disavanzo modesto, sostenibile a fronte dell'avanzo, il caso sociale è robusto e fortemente positivo, il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità, in piena coerenza con la cautela metodologica già enunciata, per cui il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali e non in un risparmio di bilancio che lo studio si astiene dal rivendicare. La parte che segue sottopone questo quadro alla prova dell'incertezza e della modellazione.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte F

Modellazione e incertezza

Modello decisionale, sensibilità deterministica e probabilistica, scenari, verifica empirica e valore dell'informazione

Quinto dominio dell'HTA · la robustezza della valutazione economica

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte completa il dominio economico sottoponendo i risultati della Parte E alla prova della modellazione e dell'incertezza. Come per le altre regioni, il modello è invariante e muta solo ciò che attiene alla verifica empirica locale. La parte descrive il modello decisionale e i suoi parametri (capitolo F.1); ne saggia la robustezza con l'analisi di sensibilità deterministica (F.2) e probabilistica (F.3); ne esplora gli scenari di copertura (F.4); e definisce il disegno della verifica empirica e il valore dell'informazione (F.5). Per il Trentino-Alto Adige quest'ultimo capitolo si avvale di una condizione propria: poiché gli assetti delle due Province sono già operanti, la prova empirica dispone di una base di dati propri più estesa che altrove, e la strutturazione progressiva del modello pieno fra i comprensori delle due Province offre l'opportunità di impostare una rilevazione uniforme e interoperabile, presupposto di un'evidenza locale solida.

F.1 Il modello decisionale e i suoi parametri

Poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l'orizzonte direttamente osservabile, lo studio li proietta nel tempo mediante un modello decisionale, e ne rende esplicite le assunzioni.^{[616][617][618]} La storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%.^[619] A ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita, trattati come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l'incertezza.^[620] Nel caso base l'intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell'ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità.^[621] La tabella seguente riepiloga i parametri principali del modello.

Parametro del modello	Valore
Stati clinici	Benessere o sottosoglia, episodio, cronicità, recupero
Orizzonte temporale	Cinque anni, con cicli successivi
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti
Costo per ciclo (recupero)	~ 40 euro
Costo per ciclo (cronicità)	~ 700 euro
Costo dell'intervento	~ 300 euro una tantum
Trattamento dell'incertezza	Parametri come distribuzioni di probabilità

Tabella F.1. I parametri principali del modello di Markov (comune a tutti gli studi della serie).

F.2 L'analisi di sensibilità deterministica

La robustezza del risultato è saggiata, in prima istanza, variando un parametro per volta entro intervalli plausibili. La variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. ^[622] L'ordinamento dei parametri per influenza mostra che l'esito è più sensibile all'efficacia clinica e al costo evitato della cronicità, e meno agli altri parametri; ciò orienta le priorità di raccolta dei dati verso le grandezze più influenti. ^[623]

F.3 L'analisi di sensibilità probabilistica

In seconda istanza, la robustezza è saggiata facendo variare simultaneamente tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni, su diecimila simulazioni. L'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. ^[624] La curva di accettabilità conferma che alla soglia convenzionale la probabilità di convenienza è prossima al 90% e cresce per soglie superiori, mantenendosi elevata anche a soglie molto inferiori. ^[625] La tabella seguente riepiloga gli esiti della sensibilità probabilistica.

Esito della sensibilità probabilistica	Valore
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	88,9% delle simulazioni
Probabilità di dominanza	84,6% delle simulazioni
Beneficio monetario netto medio per paziente	~ 7.815 euro
Intervallo di confidenza al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 euro
Numero di simulazioni	10.000

Tabella F.2. Gli esiti dell'analisi di sensibilità probabilistica (per paziente).

F.4 Gli scenari di copertura e l'incertezza aggregata

Gli scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; la dotazione delle proposte di legge in itinere corrisponde a un punto d'ingresso iniziale inferiore allo scenario conservativo, prima tappa di un percorso di estensione progressiva.^[626] È in questa sede che va ribadita una distinzione di onestà analitica: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema.^[627]

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

Il disegno della verifica empirica costituisce, per il Trentino-Alto Adige, un capitolo da impostare con cura. Poiché la strutturazione del modello pieno avverrà in tempi differenziati fra i comprensori e i distretti delle due Province, la verifica controfattuale può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione fra i territori sono impiegati a fini valutativi: gli assetti già operanti consentono di rilevare una linea di base più ricca che altrove e l'attivazione scaglionata fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto.^[628] L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il controllo sintetico, a partire dai dati già disponibili dagli assetti esistenti e dalla progressione differenziata della strutturazione fra i comprensori delle due Province.^[629] L'analisi del valore dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione del Trentino-Alto Adige, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle due aziende sanitarie provinciali e l'impostazione di un flusso uniforme e interoperabile dei dati di esito fra le due Province.^[630] Gli assetti già operanti consentono così di affinare le stime oltre i soli benchmark, conducendo il territorio, in modo programmato, verso una valutazione fondata in misura crescente su dati propri.^[631] La sintesi è univoca: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione e consolidamento dei dati, e la condizione di regione ad attuazione parziale impone di ancorare inizialmente la prova ai benchmark, valorizzando l'opportunità di una rilevazione ben progettata. La parte che segue affronta l'equità e l'impatto distributivo.^[632]

Priorità di ricerca	Finalità	Rilevanza
Conti certificati delle due aziende sanitarie provinciali	Sostituire le stime per quota con dati reali	Massima
Consolidamento dei dati degli assetti esistenti	Uniformare e completare l'evidenza propria fra le due Province	Massima
Tassi di intercettazione e costi evitati	Ridurre l'incertezza sulle grandezze aggregate	Alta
Efficacia clinica nel contesto locale	Corroborare il parametro più influente	Alta

Tabella F.3. Le priorità di ricerca derivanti dall'*****analisi del valore dell'*****informazione.

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte G

Equità e impatto distributivo

Gradiente sociale, assi territoriali del divario, barriere di accesso, costo-efficacia distributiva

Dominio dell'HTA · i pazienti e l'equità

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte affronta il dominio dell'equità, che la valutazione di tecnologia sanitaria tiene distinto dall'efficienza. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i dati distributivi, ancorati al Trentino-Alto Adige. La parte definisce il quadro dell'equità e il gradiente sociale (capitolo G.1); analizza l'asse territoriale e quello linguistico del divario e le barriere di accesso (G.2); descrive gli strumenti attraverso cui il servizio agisce sull'equità (G.3); e presenta l'analisi di costo-efficacia distributiva con le sue implicazioni allocative (G.4). Il tratto distintivo del Trentino-Alto Adige è la compresenza di un divario territoriale — centri urbani contro valli alpine a popolazione dispersa — e di un divario linguistico, poiché l'accesso effettivo richiede il servizio nella lingua del residente, tedesco, italiano o ladino; l'intervento può ridurre tali divari, a condizione di un'allocazione modulata per il bisogno e per la lingua, e l'armonizzazione fra le due Province riduce le disomogeneità fra i residenti.

G.1 Il quadro dell'equità e il gradiente sociale

L'analisi distributiva costituisce un dominio proprio della valutazione, poiché un intervento efficiente nel complesso può nondimeno accrescere o ridurre le disuguaglianze; lo studio ne misura l'effetto con l'analisi di costo-efficacia distributiva.^{[633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646]} Il punto di partenza è il gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori.^[647] A questo gradiente si sommano barriere di accesso geografiche, linguistiche e culturali, oltre allo stigma; nel Trentino-Alto Adige la barriera linguistica e culturale è centrale, poiché il servizio deve essere disponibile in tedesco, italiano e ladino, e ad essa si affiancano la barriera geografica delle valli alpine a popolazione dispersa e quella generazionale; quanto alla barriera economica, gli assetti delle due Province sono disomogenei — il modello trentino prevede un ticket, il Servizio dell'Alto Adige è pubblico — e l'armonizzazione in un modello pieno è occasione per ridurre tale disomogeneità.^[648]

G.2 I due assi del divario territoriale

La specificità distributiva del Trentino-Alto Adige risiede nella struttura del divario territoriale e in quella, distintiva, del divario linguistico, cui si aggiunge la dimensione generazionale.^[649] Il primo asse, territoriale, separa i centri urbani di Trento, Bolzano e Merano dalle valli alpine a popolazione dispersa, dove l'orografia e le distanze rendono l'accesso più difficoltoso; pur in presenza di servizi di buona qualità, la copertura capillare delle valli richiede un'organizzazione dedicata.^[650] Il secondo asse, linguistico e proprio di questo territorio, attiene alla necessità che il servizio sia disponibile nella lingua del residente — tedesco, italiano o ladino — perché l'accesso sia effettivo per tutti i gruppi, secondo la tutela costituzionale.^[651] La tabella seguente sintetizza i due assi e le leve di riequilibrio.

Asse del divario	Caratterizzazione	Leva di riequilibrio
Centri urbani / valli alpine	Valli a popolazione dispersa, distanti dai centri maggiori, con orografia che ostacola l'accesso	Telepsicologia assistita; presenza programmata di primo livello nelle valli
Gruppi linguistici	Tedesco, italiano e ladino, con tutela costituzionale; accesso effettivo solo nella lingua del residente	Personale plurilingue; erogazione in tedesco, italiano e ladino; telepsicologia per la lingua a distanza
Disagio giovanile	Prevalente in una popolazione fra le più giovani d'Italia; bassa propensione al ricorso spontaneo	Intercettazione precoce; presenza presso scuole e atenei di Trento e Bolzano

Tabella G.1. Gli assi del divario territoriale e linguistico del Trentino-Alto Adige, la dimensione generazionale e le leve di riequilibrio.

G.3 Gli strumenti dell'equità

Il servizio agisce sull'equità attraverso meccanismi precisi. La prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano parte delle barriere e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso; nel Trentino-Alto Adige il pieno effetto pro-equità opera attraverso la prossimità nelle valli, l'erogazione nella lingua del residente e l'armonizzazione degli assetti fra le due Province, che riduce le disomogeneità fra i residenti dei due territori.^[652] La telepsicologia assistita avvicina l'offerta alle valli alpine a popolazione dispersa e consente di mettere a disposizione, anche a distanza, personale della lingua del paziente, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, estendendo la copertura proprio dove l'accesso è più difficile.^[653] La competenza linguistica è dirimente e centrale, poiché il servizio deve essere erogato in tedesco, italiano e ladino, mentre quella nell'intercettare il disagio giovanile assicura che il servizio raggiunga adolescenti e giovani adulti, fascia a elevato bisogno e a basso ricorso spontaneo.^[654]

G.4 La costo-efficacia distributiva e le implicazioni allocative

L'analisi di costo-efficacia distributiva indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, poiché i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto.^[655] Perché questo potenziale si realizzi, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle valli alpine più isolate e garantendo la disponibilità di personale in tedesco, italiano e ladino secondo la composizione dei territori: un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un'allocazione ponderata per il bisogno e per la lingua li riduce.^[656] Va inoltre tenuto presente che, nel Trentino-Alto Adige, il canale della mobilità costituisce una leva di equità trascurabile per questo intervento, poiché le due Province attraggono pazienti, sicché l'equità si gioca prevalentemente sull'accesso interno; mentre l'armonizzazione degli assetti fra le due Province rappresenta, sul piano dell'equità, un vantaggio strutturale, poiché riduce le disomogeneità fra i residenti dei due territori.^[657] Esiste infine un rischio di iniquità inversa: se la strutturazione del modello pieno privilegiasse, per facilità organizzativa, i centri urbani già meglio serviti o un solo gruppo linguistico, l'effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell'allocazione, assicurando la copertura delle valli e l'erogazione in tutte le lingue del territorio.^[658] La sintesi è che l'intervento è favorevole all'equità sull'asse territoriale e su quello linguistico e sulla dimensione generazionale, e che l'armonizzazione fra le due Province ne rafforza la natura pro-equità; a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno e che siano garantite la telepsicologia per le valli, l'erogazione nelle diverse lingue e l'attenzione al disagio

giovanile, la raccomandazione è di orientare fin dalla strutturazione del modello un’allocazione pro-equità che dia di più dove il bisogno è maggiore, nelle valli e fra i gruppi linguistici minoritari.^[659] La tabella seguente riepiloga l’impatto distributivo atteso.

Dimensione distributiva	Esito per il Trentino-Alto Adige
Efficienza complessiva	Intervento costo-efficace e dominante per paziente
Direzione dell’effetto distributivo	Favorevole all’equità: maggiori benefici nei gruppi a più alto bisogno
Condizione di realizzazione	Allocazione modulata per il bisogno (valli alpine) e per la lingua (tedesco, italiano, ladino)
Strumenti abilitanti	Prossimità, armonizzazione fra le due Province, telepsicologia, personale plurilingue, intercettazione del disagio giovanile
Rischio da prevenire	Iniquità inversa se la strutturazione privilegia i centri urbani o un solo gruppo linguistico

Tabella G.2. L ‘*******impatto distributivo atteso dell’*******intervento e le sue condizioni.

**STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL ·
APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO**

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Competenza e forma dell’atto, rapporto di lavoro, governance, tutele etiche e protezione dei dati

Domini dell’HTA · aspetti giuridici, etici e organizzativi

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte affronta congiuntamente i domini giuridico, organizzativo ed etico, che la valutazione tiene distinti ma interdipendenti. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati al Trentino-Alto Adige. La parte tratta il profilo giuridico — la competenza, la forma dell’atto, il rapporto di lavoro e i livelli essenziali (capitolo H.1); il profilo organizzativo — l’assetto e la governance del servizio (H.2); il profilo etico — le tutele a garanzia dei pazienti (H.3); e la sintesi dei tre profili (H.4). Il tratto distintivo del Trentino-Alto Adige emerge sul piano giuridico: la materia sanitaria è di competenza delle due Province autonome, ciascuna dotata di un proprio Servizio sanitario e di forme di psicologia territoriale già operanti, sicché la condizione abilitante non è l’approvazione di una legge regionale, ma la strutturazione del servizio in un modello pieno e la sua armonizzazione fra i due ordinamenti provinciali, nel rispetto della rispettiva autonomia.

H.1 Il profilo giuridico

La fattibilità dell’intervento dipende dal presidio congiunto dei tre profili, una debolezza in uno solo dei quali ne comprometterebbe l’esito.^{[660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675]} Sul piano giuridico, la materia sanitaria è attribuita alle due Province autonome in forza dello statuto speciale, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — originata dal giudizio sulla legge campana, di cui ha

riconosciuto la legittimità — conferma la possibilità di disciplinare il servizio nel rispetto dei principi statali: entro questa cornice ciascuna Provincia ha esercitato il proprio titolo in modo autonomo, il Trentino con la legge provinciale del 2016 di convenzione con studi privati, l’Alto Adige con il proprio Servizio psicologico territoriale.^[676] Qui si colloca la specificità del territorio: disponendo già di assetti operanti in entrambe le Province, la decisione giuridica rilevante non è l’approvazione di una norma regionale, ma la strutturazione del servizio in un modello pieno e la sua armonizzazione fra i due ordinamenti.^[677] I rapporti di lavoro sono diversi nei due assetti: convenzionale e libero-professionale, con ticket, in Trentino; pubblico, nel Servizio sanitario provinciale, in Alto Adige. L’armonizzazione dovrà comporre tali differenze, anche quanto alla compartecipazione del paziente.^[678] Quanto ai livelli essenziali di assistenza, la psicologia delle cure primarie non vi è ancora esplicitamente ricompresa; entrambe le Province finanziano però integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto, senza apporto statale e in avanzo, sicché il finanziamento del modello pieno è agevolmente disponibile entro l’autonomia di ciascuna Provincia.^[679] Il servizio si inserisce coerentemente nella cornice degli standard territoriali e delle Case della Comunità,^[680] e si rapporta ai Centri di Salute Mentale per integrazione e non per sovrapposizione, precedendoli e alleggerendoli.^[681] La tabella seguente riepiloga i profili giuridici.

Profilo giuridico	Contenuto per il Trentino-Alto Adige
Competenza	Provinciale, in forza dello statuto speciale; due Province autonome con Servizi sanitari distinti; Corte Cost. 241/2021 (legge campana) conferma il titolo a disciplinare
Forma dell’atto	Due ordinamenti provinciali: legge provinciale di Trento (2016) di convenzione; Servizio psicologico territoriale dell’Alto Adige; da strutturare e armonizzare in un modello pieno
Rapporto di lavoro	Trentino: convenzionale libero-professionale, con ticket; Alto Adige: pubblico nel Servizio sanitario provinciale; da armonizzare
Livelli essenziali di assistenza	Non ancora ricompresi; autofinanziamento integrale con i 9/10 del gettito, senza apporto statale, in avanzo; copertura agevolmente disponibile
Cornice territoriale	Decreto Ministeriale 77/2022; inserimento nelle Case della Comunità
Rapporto con i servizi specialistici	Integrazione con i Centri di Salute Mentale, che il servizio precede e alleggerisce

Tabella H.1. I profili giuridici del servizio nel Trentino-Alto Adige.

H.2 Il profilo organizzativo e la governance

Sul piano organizzativo, la strutturazione del servizio nel Trentino-Alto Adige si misura con la presenza di due Servizi sanitari provinciali distinti e pienamente autonomi — l’APSS del Trentino e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (Sabes) — articolati in comprensori e distretti, su un territorio montano e plurilingue, sicché la sfida centrale è garantire la strutturazione in un modello pieno e l’armonizzazione fra i due sistemi, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna Provincia.^[682] Il consolidamento poggia su una sede di coordinamento fra le due Province, l’APSS e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, i due Assessorati alla salute, l’Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei dell’Università di Trento e della Libera Università di Bolzano, cui spetta definire indirizzi condivisi e impostare un monitoraggio comparabile fra i due sistemi, valorizzando l’esperienza del modello trentino e del Servizio dell’Alto Adige.

[683] In questo quadro l’Ordine degli Psicologi della Regione Trentino-Alto Adige concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione, comprese le competenze linguistiche, e alla vigilanza deontologica. [684] La tabella seguente sintetizza l’assetto organizzativo e di governance.

Elemento organizzativo	Assetto per il Trentino-Alto Adige
Articolazione del sistema	Due Servizi sanitari provinciali autonomi: APSS (Trentino) e Azienda Sanitaria dell’Alto Adige - Sabes; articolati in comprensori e distretti
Coordinamento	Sede di coordinamento fra le due Province autonome e i due Assessorati alla salute; nel rispetto dell’autonomia di ciascuna Provincia
Sfida organizzativa	Strutturazione in un modello pieno e armonizzazione fra i due sistemi provinciali, su territorio montano e plurilingue
Regia della strutturazione	Indirizzi condivisi e monitoraggio comparabile fra i due sistemi, valorizzando gli assetti già operanti
Soggetti coinvolti	Due Province, APSS e Sabes, Ordine professionale, medicina generale e pediatria, atenei di Trento e Bolzano

Tabella H.2. L ‘*****assetto organizzativo e la governance dell*****’istituzione.

H.3 Il profilo etico

Sul piano etico, lo studio adotta cautele a tutela dei pazienti. Le situazioni che coinvolgono minori e persone vulnerabili sono presidiate impiegando gli strumenti di esito nei soli punteggi complessivi e indirizzando le situazioni di rischio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza entrare nel merito dei metodi clinici. [685] L’intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un’informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell’efficacia stessa del sostegno. [686] Gli strumenti di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, in conformità al quadro europeo e ai requisiti sui dispositivi medici, [687] il trattamento dei dati è conforme alla normativa e ispirato alla minimizzazione, [688] e la responsabilità delle decisioni cliniche resta interamente in capo al professionista, cui gli strumenti forniscono un ausilio non vincolante. [689]

H.4 Sintesi dei profili

La ricognizione dei tre profili conduce a una conclusione netta: il profilo giuridico, quello organizzativo e quello etico sono tutti presidiati, e la condizione abilitante dell’intervento non è, per il Trentino-Alto Adige, l’approvazione di una legge regionale, ma la strutturazione del servizio in un modello pieno e la sua armonizzazione fra i due ordinamenti provinciali, agevolata dalla piena autonomia finanziaria e dall’avanzo di bilancio delle due Province. È questo il passaggio da cui dipende la piena operatività del servizio. [690] Definiti i profili, la parte che segue affronta l’attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

I cinque casi, il dimensionamento ex novo, le fasi di attuazione, i rischi e le mitigazioni

Five Case Model · la realizzabilità della decisione

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità dell'intervento, organizzandole secondo il modello a cinque casi della decisione di investimento pubblico. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati al Trentino-Alto Adige. La parte espone i cinque casi (capitolo I.1); definisce il dimensionamento a partire dagli assetti esistenti e le fasi di attuazione (I.2); tratta il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma (I.3); analizza la sostenibilità finanziaria e organizzativa (I.4); e individua i rischi e le mitigazioni (I.5). Il tratto distintivo del Trentino-Alto Adige è che l'attuazione muove da assetti già operanti in entrambe le Province autonome: non l'istituzione, ma la strutturazione in un modello pieno e l'armonizzazione fra i due ordinamenti provinciali, agevolata dalla piena autonomia finanziaria e dall'avanzo di bilancio delle due Province.

I.1 I cinque casi della decisione

Lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile.^{[691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705]}
^[706] Il caso strategico è solido: la strutturazione del servizio è coerente con gli standard territoriali, con le Case della Comunità e con la programmazione provinciale di salute mentale, e nel Trentino-Alto Adige porta a un modello pieno gli assetti che le due Province già esercitano.^[707] Il caso economico rinvia ai risultati già esposti, nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di disavanzo modesto, sostenibile a fronte dell'avanzo, e un caso sociale fortemente positivo.^[708] Il caso commerciale si avvale degli assetti già operanti e di un bacino professionale alimentato dagli atenei di Trento e Bolzano, con psicologi qualificati anche nelle competenze linguistiche in tedesco, italiano e ladino.^[709] Il caso finanziario presenta un costo contenuto, pari allo 0,3-0,5% della spesa sanitaria, agevolmente disponibile entro l'autonomia di ciascuna Provincia, che finanzia integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto e opera in avanzo.^[710] Il caso gestionale dipende da una sede di coordinamento fra le due Province autonome che raccordi l'APSS e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (Sabes), nel rispetto della rispettiva autonomia.^[711] La tabella seguente riepiloga i cinque casi.

Caso	Contenuto per il Trentino-Alto Adige
Strategico	Coerenza con DM 77/2022, Case della Comunità e programmazione salute mentale; strutturazione in un modello pieno degli assetti già operanti nelle due Province
Economico	Rapporto beneficio-costi 4,1-5,5 a uno; dominanza per paziente; caso sociale fortemente positivo
Commerciale	Assetti già operanti; bacino dagli atenei di Trento e Bolzano; psicologi con competenze linguistiche (tedesco, italiano, ladino)
Finanziario	Costo 0,3-0,5% della spesa sanitaria; autofinanziamento integrale con i 9/10 del gettito, senza apporto statale, in avanzo; copertura agevolmente disponibile
Gestionale	Sede di coordinamento fra le due Province autonome (APSS e Sabes), nel rispetto dell'autonomia di ciascuna

Tabella I.1. I cinque casi della decisione di investimento pubblico.

I.2 Il dimensionamento dal nucleo di avvio e le fasi di attuazione

A differenza del Lazio, che dimensiona il servizio da zero, il Trentino-Alto Adige muove dagli assetti già operanti nelle due Province e li struttura verso un fabbisogno a regime dell'ordine di 240 psicologi nello scenario espansivo; la strutturazione procede per gradi attraverso gli scenari conservativo, di base ed espansivo. ^[712] L'attuazione si articola perciò in tre fasi: una fase di strutturazione, con la definizione del modello pieno a partire dagli assetti esistenti; una fase di armonizzazione, nella quale i due ordinamenti provinciali vengono progressivamente allineati; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato. La progressione differenziata fra i comprensori delle due Province coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F. ^[713] La tabella seguente riepiloga le fasi.

Fase	Contenuto	Dimensionamento indicativo
Strutturazione	Definizione del modello pieno dagli assetti esistenti	Assetti già operanti nelle due Province
Armonizzazione	Allineamento progressivo dei due ordinamenti provinciali	verso ~ 120-180 psicologi
Regime	Dimensionamento adeguato al fabbisogno	fino a ~ 240 psicologi

Tabella I.2. Le fasi di attuazione e il dimensionamento progressivo.

I.3 Reclutamento, formazione e cronoprogramma

La strutturazione richiede il reclutamento e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino professionale e gli atenei di Trento e Bolzano costituiscono una base favorevole, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze, con particolare attenzione al disagio giovanile e alle competenze linguistiche in tedesco, italiano e ladino. ^[714] Il cronoprogramma si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; la strutturazione non è subordinata all'approvazione di una legge regionale, ma alla definizione del modello pieno e alla sua armonizzazione fra i due ordinamenti provinciali, agevolata dall'autonomia finanziaria e dall'avanzo di bilancio. ^[715]

I.4 La sostenibilità finanziaria e organizzativa

La sostenibilità finanziaria, nel Trentino-Alto Adige, è la più solida della serie: entrambe le Province autonome finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto, senza apporto statale, e operano in avanzo, con la spesa pro-capite più alta d'Italia, sicché il costo del modello pieno è agevolmente sostenibile entro l'autonomia di ciascuna Provincia; l'eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe in futuro la stabilità.^[716] La sostenibilità organizzativa dipende invece dalla capacità di garantire la strutturazione in un modello pieno e l'armonizzazione fra i due Servizi sanitari provinciali, su un territorio montano e plurilingue, attraverso una sede di coordinamento fra le due Province e indirizzi condivisi.^[717] L'avanzamento è seguito mediante indicatori di processo raccolti attraverso un sistema impostato in forma comparabile e interoperabile fra le due Province.^[718]

I.5 I rischi e le mitigazioni

L'attuazione presenta rischi propri della posizione del Trentino-Alto Adige: la difficoltà di armonizzare due Servizi sanitari provinciali pienamente autonomi, con ordinamenti e assetti diversi; il maggior costo unitario del personale, fra i più alti del Paese; la necessità di garantire l'erogazione in tre lingue; e il rischio che la strutturazione privilegi i centri urbani a scapito delle valli alpine o un solo gruppo linguistico.^[719] Tali rischi sono fronteggiati con una sede di coordinamento fra le due Province e indirizzi condivisi, con la valorizzazione degli assetti già operanti che consente un apprendimento progressivo, e con un'allocazione pro-equità che orienta la strutturazione verso le valli a maggiore bisogno e garantisce l'erogazione in tutte le lingue del territorio; l'avanzo di bilancio e il sostegno dell'Ordine professionale concorrono a ridurre l'incertezza.^[720] La sintesi è che l'intervento è attuabile e sostenibile, e che la leva propria del Trentino-Alto Adige è la strutturazione del servizio in un modello pieno e la sua armonizzazione fra i due ordinamenti provinciali: il territorio muove da assetti già operanti, da un bacino professionale adeguato e dalla piena autonomia finanziaria, con bilanci in avanzo, sicché le condizioni di fattibilità sono fra le più favorevoli della serie.^[721] La tabella seguente riepiloga i rischi e le relative mitigazioni; la parte che segue affronta il monitoraggio e la valutazione ex post.

Rischio	Mitigazione
Difficoltà di armonizzazione fra due Servizi sanitari provinciali	Sede di coordinamento fra le due Province; indirizzi condivisi; monitoraggio comparabile
Maggior costo unitario del personale (fra i più alti d'Italia)	Dimensionamento prudenziale; piena copertura dall'avanzo di bilancio
Erogazione in tre lingue (tedesco, italiano, ladino)	Personale plurilingue; telepsicologia per la lingua a distanza; formazione linguistica
Allocazione non equa (rischio centri urbani o un solo gruppo linguistico)	Criteri di equità espliciti; copertura delle valli; erogazione in tutte le lingue del territorio

Tabella I.3. I rischi dell'attuazione e le relative mitigazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte L

Monitoraggio e valutazione ex post

Disegno controfattuale prospettico, batteria di indicatori, cruscotto regionale e clausola valutativa

Inferenza causale quasi-sperimentale · la valutazione ex post

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Questa parte definisce il sistema di monitoraggio e la valutazione ex post dell'intervento, attraverso cui l'istituzione del servizio si traduce in apprendimento e rendicontazione. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e muta ciò che attiene al disegno valutativo locale. La parte espone le finalità e l'impianto della valutazione (capitolo L.1); il disegno controfattuale e i metodi di stima (L.2); la batteria degli indicatori, organizzata per categorie (L.3); il cruscotto di monitoraggio e la clausola valutativa (L.4); e la sintesi (L.5). Il tratto distintivo del Trentino-Alto Adige è che, disponendo di assetti già operanti in entrambe le Province, la valutazione può fondarsi su una base informativa più ricca di quella delle regioni che partono da zero, e le clausole valutative — da corredare alla strutturazione nei rispettivi ordinamenti provinciali — vanno costruite assicurando la comparabilità fra le due Province.

L.1 Finalità e impianto della valutazione

Il monitoraggio e la valutazione ex post servono a rendere conto dell'impiego delle risorse, ad apprendere dall'esperienza e a correggere il corso dell'attuazione; non sono un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l'istituzione del servizio diventa apprendimento istituzionale, ancorato a una clausola valutativa. [722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740] L'impianto distingue i tre livelli della struttura, del processo e dell'esito, in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti. [741]

L.2 Il disegno controfattuale e i metodi

Il disegno della valutazione d'impatto costituisce, per il Trentino-Alto Adige, un punto di forza dello studio. Poiché la strutturazione del modello pieno avverrà in tempi differenziati fra i comprensori e i distretti delle due Province, la valutazione può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione fra i territori sono impiegati a fini valutativi. [742] Gli assetti già operanti offrono una linea di base più ricca di quella delle regioni che partono da zero, e il diverso grado di strutturazione fra i comprensori delle due Province consente di costruire termini di confronto interni, fondando la stima su dati propri. [743] L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, con la progressione differenziata della strutturazione fra i comprensori a fornire la variazione necessaria all'identificazione. [744]

L.3 La batteria degli indicatori

Il servizio è osservato attraverso una batteria di indicatori organizzata per categorie. Gli indicatori di struttura misurano la capacità installata — sedi, incarichi, ore, dotazione, copertura. [745] Gli indicatori di processo misurano il funzionamento — prese in carico, attesa, colloqui, invio appropriato. [746] Gli indicatori di esito clinico misurano il beneficio diretto — miglioramento, recupero, remissione. [747] Gli indicatori di esito di sistema misurano l'effetto sul resto del sistema — pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri. [748] Gli indicatori economici consentono di verificare ex post le stime e di sostituire i valori ricostruiti con quelli effettivi. [749] Gli indicatori di equità, disaggregati per area, per gruppo linguistico e per fasce di età, verificano che il servizio

riduca i divari fra centri urbani e valli alpine e fra i gruppi linguistici del territorio, con attenzione congiunta al disagio giovanile e all'effettiva disponibilità del servizio in tedesco, italiano e ladino.^[750] Gli indicatori di qualità integrano la misurazione con la dimensione dell'esperienza.^[751] Gli indicatori di mobilità, infine, sono monitorati ma costituiscono un esito atteso trascurabile, poiché le due Province attraggono pazienti.^[752] L'insieme conta dell'ordine di cinquantotto indicatori in otto categorie, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile.^[753] La tabella seguente riepiloga le categorie.

Categoria	Contenuto (dell'ordine di 58 indicatori complessivi)
Struttura	Sedi attivate, incarichi, ore, dotazione, copertura del fabbisogno
Processo	Prese in carico, attesa al primo colloquio, colloqui per persona, invio appropriato
Esito clinico	Miglioramento, recupero, remissione (strumenti validati, punteggi complessivi)
Esito di sistema	Accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili, specialistica impropria
Economici	Costo, risparmi diretti, ricadute sociali, rapporto beneficio-costi su dati reali
Equità	Copertura e accesso per area (centri urbani, valli alpine), per gruppo linguistico (tedesco, italiano, ladino) e per fasce di età
Qualità	Soddisfazione, appropriatezza, continuità del rapporto
Mobilità	Monitorata; esito atteso trascurabile (le Province attraggono pazienti)

Tabella L.1. Le otto categorie della batteria di indicatori.

L.4 Il cruscotto regionale e la clausola valutativa

Gli indicatori confluiscono in un cruscotto di monitoraggio aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; la titolarità del cruscotto è condivisa fra le due Province autonome, l'APSS e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (Sabes), che ne assicurano l'alimentazione comparabile e interoperabile.^[754] Lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa; il compito è corredare la strutturazione del modello pieno di clausole valutative, nei rispettivi ordinamenti provinciali, che impegnino le Giunte a riferire periodicamente ai Consigli provinciali.^[755] La raccolta dei dati poggia sui sistemi informativi delle due aziende sanitarie provinciali, da impostare in forma comparabile e interoperabile fra i due sistemi.^[756] La valutazione si articola infine in un monitoraggio in itinere, che accompagna l'attivazione progressiva, e in una valutazione ex post a regime.^[757] La tabella seguente riepiloga la governance valutativa.

Elemento della governance valutativa	Scelta per il Trentino-Alto Adige
Disegno d'impatto	Esperimento a cunei progressivi fra i comprensori delle due Province, con linea di base dagli assetti già operanti
Linea di base	Dati già disponibili dagli assetti esistenti e progressione differenziata della strutturazione fra i comprensori
Titolarità del cruscotto	Condivisa fra le due Province (APSS e Sabes), con alimentazione comparabile e interoperabile
Clausola valutativa	Da corredare alla strutturazione nei rispettivi ordinamenti provinciali; relazione periodica ai Consigli provinciali
Flusso informativo	Sistemi informativi delle due aziende sanitarie provinciali; comparabile e interoperabile fra i due sistemi
Tempi	In itinere (accompagnamento della strutturazione) ed ex post (effetto a regime)

Tabella L.2. La governance della valutazione e il cruscotto regionale.

L.5 Sintesi del monitoraggio

La valutazione è la condizione per trasformare la strutturazione del servizio in apprendimento, e il Trentino-Alto Adige può fondarla su una base informativa più ricca di quella delle regioni che partono da zero; perché ciò si realizzi, occorre corredare la strutturazione di clausole valutative nei rispettivi ordinamenti provinciali e impostare un flusso informativo comparabile e interoperabile fra le due Province, valorizzando l'esperienza già maturata.^[758] Definito il sistema di monitoraggio, la parte conclusiva compone i risultati dei diversi domini in una sintesi multidimensionale e formula le raccomandazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Composizione dei domini, analisi multi-criterio, raccomandazioni operative e conclusione

Analisi multi-criterio · dalla valutazione alla raccomandazione

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclude lo studio componendo i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo e traducendolo in raccomandazioni operative. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i contenuti, ancorati al Trentino-Alto Adige. La parte richiama la sintesi per dominio (capitolo M.1); espone l'analisi multi-criterio e il confronto fra l'intervento e il non intervento (M.2); formula la raccomandazione principale e il dimensionamento (M.3); ne precisa le condizioni e la lacuna da colmare (M.4); e chiude con la collocazione nella serie e la conclusione (M.5). Il tratto distintivo del Trentino-Alto Adige percorre l'intera

sintesi: è il territorio ripartito in due Province autonome con Servizi sanitari distinti, fra i più giovani, ricchi e sani d’Italia, a piena autonomia finanziaria e in avanzo di bilancio, che, dodicesimo della serie, è chiamato non a istituire un servizio, ma a strutturare in un modello pieno gli assetti già operanti nelle due Province e ad armonizzarli.

M.1 La sintesi per dominio

La parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini impiegando l’analisi multi-criterio, che integra in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie, ponderandole secondo criteri espliciti.^{[759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774]} Il quadro che emerge dai domini è coerente: il bisogno è ampio in un territorio fra i più giovani d’Italia, con il disagio giovanile in primo piano e la dimensione plurilingue; l’efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida, affinata dai dati propri degli assetti già operanti; il quadro economico distingue un caso finanziario di disavanzo modesto, agevolmente sostenibile a fronte dell’avanzo, da un caso sociale fortemente positivo; l’equità è favorevole sull’asse territoriale e su quello linguistico e sulla dimensione generazionale, ed è rafforzata dall’armonizzazione fra le due Province; la fattibilità è quella della strutturazione di assetti già operanti, agevolata dalla piena autonomia finanziaria; il monitoraggio può fondarsi su una base informativa più ricca che altrove.^[775] La tabella seguente riepiloga il giudizio per dominio.

Dominio	Giudizio sintetico per il Trentino-Alto Adige
Bisogno e contesto	Ampio; territorio fra i più giovani e ricchi d’Italia, due Province autonome, disagio giovanile, valli alpine, plurilinguismo
Efficacia clinica	Evidenza internazionale solida; affinata dai dati propri degli assetti già operanti nelle due Province
Valutazione economica	Caso finanziario di disavanzo modesto, sostenibile a fronte dell’avanzo; caso sociale fortemente positivo
Equità	Favorevole su asse territoriale (valli alpine) e linguistico (tedesco, italiano, ladino) e su disagio giovanile; rafforzata dall’armonizzazione
Fattibilità	Strutturazione di assetti già operanti; coordinamento fra due Province; piena autonomia finanziaria e avanzo
Monitoraggio	Disegno controfattuale su strutturazione progressiva fra i comprensori; base informativa dagli assetti già operanti

Tabella M.1. La sintesi dei domini della valutazione.

M.2 L’analisi multi-criterio

Il giudizio complessivo è formalizzato con l’analisi multi-criterio, che impiega otto criteri, ciascuno con un peso esplicito, e confronta l’intervento con l’alternativa del non intervento.^[776] I pesi adottati — efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell’evidenza 10%, coerenza strategica 5% — sono comuni a tutta la serie.^[777] La media ponderata dei punteggi dell’intervento è dell’ordine di 81,0 su 100, la più elevata della serie, sostenuta dal punteggio molto alto nell’impatto sul bilancio e nella sostenibilità — che riflette la piena autonomia finanziaria e l’avanzo di bilancio delle due Province — e dai punteggi elevati nel valore sociale, nella costo-

efficacia e nella coerenza strategica, e contenuta dal punteggio più basso nella robustezza dell'evidenza.^[778] Il non intervento ottiene una media dell'ordine di 39,2 su 100, penalizzato in tutti i criteri sostanziali e sostenuto soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, oggi poco giustificata, poiché lascerebbe non strutturati e non armonizzati assetti già operanti in entrambe le Province.^[779] L'intervento prevale dunque nettamente, con uno scarto dell'ordine di quarantadue punti; il punteggio si colloca al primo posto fra le regioni esaminate, riflettendo la piena autonomia finanziaria, l'avanzo di bilancio e gli assetti già operanti.^[780] La prevalenza si mantiene al variare dei pesi entro intervalli ragionevoli, sicché la raccomandazione è robusta.^[781] La tabella seguente riporta i punteggi per criterio.

Criterio	Peso	Intervento	Non interv.
Efficacia clinica	15%	80	30
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	82	25
Impatto sul bilancio e sostenibilità	15%	90	52
Equità	15%	78	28
Valore sociale	10%	82	25
Fattibilità	10%	80	84
Robustezza dell'evidenza	10%	70	55
Coerenza strategica	5%	84	26
Punteggio complessivo ponderato	100%	81,00	39,20

Tabella M.2. L'«*****analisi multi-criterio: punteggi dell'*****» intervento e del non intervento.

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Dalla convergenza dei domini e dall'analisi multi-criterio discende la raccomandazione principale: strutturare in un modello pieno di psicologo di base gli assetti già operanti nelle due Province — il modello trentino di convenzione e il Servizio psicologico dell'Alto Adige — armonizzandoli fra i due ordinamenti provinciali e dimensionandolo verso la copertura piena del fabbisogno; è la decisione che il Trentino-Alto Adige, dotato di assetti già operanti e di piena autonomia finanziaria, è chiamato a compiere per dare al servizio una forma compiuta e omogenea.^[782] Quanto alla scala, si raccomanda di muovere dagli assetti esistenti e di procedere per gradi verso lo scenario conservativo, dell'ordine di 120 psicologi, quindi verso quello di base, dell'ordine di 180, e infine verso quello espansivo, dell'ordine di 240, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità.^[783] La tabella seguente riepiloga le raccomandazioni operative.

Ambito	Raccomandazione operativa per il Trentino-Alto Adige
Atto di attuazione	Strutturare in un modello pieno gli assetti già operanti; armonizzarli fra i due ordinamenti provinciali; valorizzare la piena autonomia finanziaria
Dimensionamento	Dagli assetti esistenti verso conservativo ~120; base ~180; espansivo ~240, per gradi
Allocazione	Pro-eguità, verso le valli alpine, i gruppi linguistici (tedesco, italiano, ladino) e il disagio giovanile
Clausola valutativa	Corredarla alla strutturazione nei rispettivi ordinamenti provinciali; relazione periodica ai Consigli provinciali
Governance	Sede di coordinamento fra le due Province (APSS e Sabes); indirizzi condivisi; flusso informativo comparabile e interoperabile
Dati	Estrarre i conti certificati delle due aziende sanitarie provinciali; consolidare i dati di esito comparabili fra le due Province

Tabella M.3. Le raccomandazioni operative.

M.4 Le condizioni e la lacuna da colmare

La raccomandazione è subordinata a condizioni precise: la costruzione di clausole valutative a corredo della strutturazione, nei rispettivi ordinamenti provinciali, l'adozione di un'allocazione pro-eguità verso le valli alpine e i gruppi linguistici, una sede di coordinamento fra le due Province e l'impostazione di un flusso informativo comparabile e interoperabile fra i due sistemi.^[784] Resta inoltre da colmare, prima della presentazione esterna, la lacuna dei dati: l'estrazione dei conti certificati delle due aziende sanitarie provinciali e il consolidamento di un flusso comparabile dei dati di esito fra le due Province consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive.^[785] Va infine ribadita la distinzione cardine: il caso finanziario per il bilancio sanitario è di disavanzo modesto, agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo, mentre il caso economico complessivo è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto.^[786]

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio sul Trentino-Alto Adige è il dodicesimo della serie, dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, il Trentino-Alto Adige occupa una posizione propria e unica — quella del territorio ripartito in due Province autonome con Servizi sanitari distinti, fra i più giovani, ricchi e sani d'Italia, a piena autonomia finanziaria e in avanzo di bilancio, che dispone già di assetti di psicologia territoriale in entrambe le Province — e che oggi è chiamato a strutturarli in un modello pieno e ad armonizzarli.^[787] Coerentemente con l'impostazione dell'intero progetto, lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico, e adotta un rapporto beneficio-costi prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, per credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica.^[788] La decisione che lo studio sostiene è, in conclusione, di strutturare in un modello pieno di psicologo di base gli assetti già operanti nelle due Province, armonizzandoli fra i due ordinamenti provinciali, dimensionandoli progressivamente al fabbisogno e

corredandoli di clausole valutative: per il Trentino-Alto Adige, dotato di assetti già operanti, di piena autonomia finanziaria e di bilanci in avanzo, ciò significa dare al servizio una forma compiuta e omogenea, a beneficio della popolazione.^[789]

**STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL ·
APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO**

Riforma «Psicologo di Base»: dai servizi esistenti alla strutturazione armonizzata nelle due Province autonome

Appendici A-E

Corredo tecnico e documentale

Caso di riferimento, strumenti di esito, dati regionali, standard di reporting, glossario

Materiali a sostegno delle Parti da A a M

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l’orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità.^{[790][791][792][793][794][795][796][797][798]} La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Servizio attivo ma parziale e a finanziamento transitorio (PNES); condizione di pre-strutturazione a regime
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Azienda Sanitaria Locale/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudenziale	Riduzione per l’ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura.^[799] La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l’analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato del Lazio, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.^[800] La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 120	~ 180	~ 240
Costo del servizio	~ 7	~ 11	~ 14
Risparmi diretti (SSR)	~ 4	~ 7	~ 10
Ricadute economico-sociali	~ 25	~ 48	~ 67
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -3	~ -4	~ -4
Saldo complessivo (caso economico)	+22	+44	+63
Rapporto beneficio-costo complessivo	~4,1:1	~5,0:1	~5,5:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell'esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario.^[801] La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura.^[802] La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori sardi impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.^[803]

Ambito	Valore per il Trentino-Alto Adige
Popolazione	~1.085.000 abitanti (ISTAT 2024), ~1,8% del totale nazionale; in crescita; Trentino 545.169, Alto Adige 539.386; fra le più giovani d'Italia; Alto Adige plurilingue (68,61% tedesco, 26,98% italiano, 4,41% ladino)
Finanziamento dei SSP	Due Servizi sanitari provinciali autonomi; autofinanziamento integrale con i 9/10 del gettito trattenuto, senza apporto statale; spesa pro-capite la più alta d'Italia; bilanci in avanzo
Mobilità sanitaria	Saldo modesto e per alcune branche attivo (le Province attraggono pazienti); canale di recupero trascurabile per questo intervento
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche dell'ordine di alcune decine di migliaia l'anno (proxy dai dati nazionali)
Farmaceutica	Consumo regionale delle categorie dei psicofarmaci
Salute mentale	~ 217.000 con disagio comune potenziale (proxy ~20%); utenza in carico ai servizi rapportata ai dati nazionali; bisogno trainato dal disagio giovanile, dallo stress lavorativo e dalla dimensione plurilingue
Funzione attuale	Assetti già operanti nelle due Province: Trentino, convenzione APSS-studi privati (legge provinciale 2016, con ticket); Alto Adige, Servizio psicologico territoriale pubblico e bilingue (Sabes); da strutturare in un modello pieno e armonizzare

Tabella C.1. I valori di ancoraggio del Trentino-Alto Adige.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione, e non estratti dai conti provinciali certificati.^[804] La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Dati degli assetti esistenti	Prese in carico, sedute ed esiti dal modello trentino di convenzione e dal Servizio dell'Alto Adige, da consolidare in forma comparabile come fonte primaria
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Provincia, comprensorio e area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[805] La tabella seguente li riepiloga.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell’evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell’intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.^[806] Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra gruppi a diversa esposizione
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità a minore esposizione
Disegno a cunei progressivi	Disegno controfattuale impiegato nel Trentino-Alto Adige, fondato sulla progressione differenziata della strutturazione del modello pieno tra i comprensori e i distretti delle due Province autonome, con una linea di base dagli assetti già operanti

Termine	Definizione
Analisi e verifica d'impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna le Giunte provinciali a riferire ai rispettivi Consigli sui risultati del servizio; nel Trentino-Alto Adige va corredata alla strutturazione del modello pieno nei rispettivi ordinamenti provinciali, e alimentata da un flusso comparabile e interoperabile fra le due Province
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell'implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall'impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d'ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l'intensità dell'intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; nella Sicilia il saldo è fra i più passivi d'Italia, ma poiché la fuga è ospedaliero-chirurgica il canale del recupero è modesto per questo intervento, limitato alla frazione territorialmente intercettabile
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di vecchiaia	Rapporto tra ultrasessantacinquenni e giovani sotto i quindici anni; nel Trentino-Alto Adige assume valori fra i più bassi d'Italia, poiché il territorio è fra i più giovani del Paese, con una natalità elevata e una speranza di vita fra le più alte
Peso morto	Quota dell'esito che si sarebbe verificata anche senza l'intervento
Ticket (compartecipazione)	Quota di costo a carico del paziente; nel Trentino-Alto Adige gli assetti sono disomogenei — il modello trentino prevede un ticket, il Servizio dell'Alto Adige è pubblico — e l'armonizzazione in un modello pieno è occasione per ridurre tale disomogeneità, con esenzioni per le fasce protette perché non ostacoli l'accesso

Termine	Definizione
Statuto speciale e autonomia finanziaria	Le due Province autonome di Trento e Bolzano finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto sul proprio territorio (statuto speciale, art. 75), senza apporto a carico dello Stato, e operano in avanzo, con la spesa pro-capite più alta d'Italia: una condizione finanziaria fra le più solide del Paese

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

81

81

Veneto — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Veneto

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione pioniera al servizio permanente. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per il Veneto, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati al Veneto. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). È la parte che rende lo studio insieme rigoroso, riproducibile e confrontabile con quello pugliese e lombardo e con quelli delle altre Regioni.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Servizio di Psicologia di Base nelle cure primarie del Veneto, inteso come realizzazione strutturata e quantificata della funzione psicologica territoriale che il Veneto ha avviato per primo in Italia, già nel 2014, in via sperimentale, e alla quale la Regione si è formalmente impegnata con la mozione consiliare che vincola la Giunta ad avviare un servizio permanente di psicologia delle cure primarie collegato alle Case di Comunità.^[807] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sul portare il servizio a regime. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante non è se introdurre la funzione — sperimentata da oltre un decennio e già oggetto di un impegno politico formale, oltre che di proposte di legge in corso d'esame — ma se strutturarla e dimensionarla: l'impegno esiste, ma un modello operativo, un dimensionamento e una copertura sono ancora da definire, a fronte di un fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 1.050 psicologi.^[808] Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 970.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale dell'ordine di 72.000 persone, in un quadro segnato da tre componenti convergenti — il disagio connesso al lavoro nella popolazione attiva di un'economia dinamica e a elevata occupazione, il bisogno dell'età anziana accentuato nel Polesine e nel Bellunese, e il disagio giovanile — e aggravato da un'erosione recente degli organici dei servizi di salute mentale e da liste di attesa prolungate.

[809] La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti veneti con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema.^[810] L'intervento è lo psicologo di base nelle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, portato a regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale coesistono una consolidata esperienza sperimentale e un impegno politico, ma non un servizio strutturato e dimensionato. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario del Veneto, con le sue nove Aziende ULSS, l'Azienda Zero, le due Aziende Ospedaliere universitarie e la rete delle Case di Comunità in costruzione. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per il Veneto
Popolazione	Residenti veneti con disagio psichico comune (~970.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Psicologo di base nelle cure primarie, primo livello e filtro, portato a regime (~530/800/1.050 incarichi)
Confronto	Condizione attuale: esperienza sperimentale e impegno politico (mozione), ma servizio non strutturato né dimensionato
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale del Veneto; nove Aziende ULSS, Azienda Zero, due Aziende Ospedaliere universitarie, Case di Comunità

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell'HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell'OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio.^[811] In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l'intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e il servizio attuale come comparatore.

^[812] Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Aziende ULSS e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale, ovvero servizio non strutturato né dimensionato a regime
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda ULSS e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso.^[813] Tale prudenza assume, per il Veneto, un rilievo particolare: poiché la regione è a saldo di mobilità attivo — attrattore netto di pazienti da altre regioni — il canale del recupero della mobilità passiva non si applica; e poiché il sistema sanitario veneto è stabilmente ai vertici nazionali per efficienza e appropriatezza, i margini di recupero diretto sono contenuti. Ne consegue che il saldo diretto risulta lievemente negativo e che il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, che lo studio stima con criteri conservativi.^[814] Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati.^[815]

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post.^[816]

Decisivo anche per il Veneto è il disegno controfattuale: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le nove Aziende ULSS, attivate in tempi diversi sotto il coordinamento dell’Azienda Zero, funge da esperimento naturale e consente di stimare l’effetto causale con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico.^[817] La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell’informazione	Parte F	Governo dell’incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell’equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell’effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell’evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l’attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, l’Azienda Zero, le Aziende ULSS e l’Ordine degli Psicologi del Veneto.^[818] In questo assetto, l’Azienda Zero — ente di governo regionale a cui sono affidate funzioni centralizzate di programmazione, acquisto e coordinamento — riveste un ruolo peculiare: costituisce il veicolo per una progettazione unitaria del servizio e per una sua attuazione omogenea ed efficiente su tutte le nove aziende, con economie di scala nella formazione, nell’acquisizione delle tecnologie e nella definizione dei protocolli. È una caratteristica che distingue il Veneto e che la valutazione assume come risorsa per l’implementazione.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza.^[819] Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull’intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici.^[820] Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo

protocolli definiti.^[821] Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto del Veneto.

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Questa parte segue la definizione del quadro e del metodo e apre i domini della valutazione affrontando il primo: il problema di salute, il bisogno e il contesto. Ne ricostruisce la dimensione demografica (capitolo B.1) ed epidemiologica (B.2), il rapporto tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3), le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4), i servizi e i flussi del sistema (B.5) e la cornice normativa e programmatica (B.6). L’obiettivo è stabilire, su basi quantitative e con i dati ancorati al Veneto, l’entità e la natura del bisogno cui il Servizio di Psicologia di Base intende rispondere, e il contesto in cui esso si inserirebbe.

B.1 Quadro demografico

Il Veneto conta una popolazione residente di 4.853.472 abitanti secondo il Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024, pari a circa l’8,2% del totale nazionale, che ne fa la quarta-quinta regione italiana per dimensione.^[822] Il profilo demografico è in invecchiamento, con un’età media di 47,1 anni, lievemente superiore alla media nazionale, e un’aspettativa di vita tra le più elevate d’Italia.^[823] La componente straniera contribuisce a un parziale ringiovanimento della struttura per età.^[824] La distribuzione territoriale è relativamente equilibrata fra sette province, secondo un modello insediativo diffuso in cui una quota rilevante della popolazione risiede in comuni di media dimensione.^[825] Ne deriva un profilo per età composito e a marcata variabilità interna, che contrappone le province più giovani della fascia centrale alle aree più anziane del Polesine e del Bellunese.^[826] La tabella seguente riepiloga il profilo demografico e socio-economico della regione.

Indicatore	Valore per il Veneto
Popolazione (Censimento 2024)	4.853.472 (~8,2% del totale nazionale)
Aspettativa di vita	~ 84 anni, tra le più elevate d’Italia
Età media	47,1 anni; ultra-ottantacinquenni oltre 200.000
Componente straniera	~ 10% dei residenti, in funzione di ringiovanimento
Articolazione del territorio	Sette province; Padova e Verona oltre 900.000 abitanti
Profilo per età	Composito: pianura produttiva più giovane; Polesine e Bellunese anziani
Articolazione sanitaria	Nove Aziende ULSS, Azienda Zero, due Aziende Ospedaliere, IOV

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico del Veneto.

B.2 Epidemiologia del bisogno

L'entità del bisogno psicologico nel Veneto si ricostruisce per proiezione dei tassi di prevalenza nazionali sulla popolazione regionale, in attesa dei dati di flusso certificati. La quota di disagio psichico comune o sottosoglia — disturbi d'ansia e depressivi di intensità lieve-moderata, reazioni di adattamento, disagio connesso a eventi di vita — si colloca nell'ordine di 970.000 persone.^[827] A essa si somma un'utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale dell'ordine di 72.000 persone.^[828] Il bisogno presenta, nel Veneto, tre componenti di particolare rilievo. La prima è il disagio giovanile: la sua dimensione è segnalata dai nuovi casi nella fascia 14-24 anni e dalla grave sottodotazione dell'offerta dedicata.^[829] La seconda è il disagio connesso al lavoro nella popolazione attiva, che in un'economia dinamica e a elevata occupazione assume un peso particolare per le ricadute sulla produttività.^[830] La terza è il bisogno dell'età anziana, accentuato nel Polesine e nel Bellunese.^[831] Una quota di questo bisogno, non intercettata a monte, si riversa impropriamente sui servizi di urgenza.^[832]

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Il confronto tra il bisogno e l'offerta strutturata definisce il gap di copertura, che nel Veneto presenta una configurazione peculiare. Sul versante dell'offerta, la regione dispone di una consolidata esperienza sperimentale, avviata per prima in Italia nel 2014, e di un impegno politico formale all'avvio di un servizio permanente, ma non ancora di un servizio strutturato e dimensionato a regime.^[833] Sul versante del fabbisogno, l'applicazione dei parametri organizzativi del modello indica una necessità a regime dell'ordine di 1.050 psicologi, a fronte di una dotazione attuale che l'Ordine professionale colloca su valori molto distanti dagli standard europei.^[834] Ne risulta una copertura del fabbisogno, in termini di servizio dimensionato, prossima a zero, in un quadro reso più critico da una recente erosione degli organici dei servizi di salute mentale e da liste di attesa prolungate.^[835] La tabella seguente sintetizza il rapporto tra domanda, offerta e gap.

Grandezza	Valore per il Veneto
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 970.000 persone
Utenza stimata in carico ai Dipartimenti	~ 72.000
Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche	~ 22.000-24.000 l'anno
Offerta territoriale strutturata attuale	Sperimentazioni pioniere e impegno (mozione 302/2022); servizio non strutturato
Fabbisogno stimato a regime	~ 1.050 psicologi
Copertura attuale del fabbisogno	~ 0%; organici dei DSM in erosione (-10% psicologi, -30% educatori)

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, che la Parte G riprende e analizza con gli strumenti propri, va anticipata qui perché concorre a definire il problema. Il divario rilevante nel Veneto non è un gradiente di deprivazione socio-economica, né una frattura tra un Nord e un Sud regionali, ma la dualità fra la pianura densamente popolata e produttiva e le aree montane del Bellunese e dell'Altopiano, anziane e in spopolamento, dove la distanza dai servizi e la rarefazione dell'offerta rendono l'accesso più difficoltoso.^[836] È una geografia dell'accesso più che del reddito, che orienta una specifica scelta di modello: l'affiancamento, alla rete territoriale, di un presidio di telepsicologia e telemonitoraggio quale condizione di accesso per le comunità montane. A questa dimensione propriamente territoriale si aggiunge una dimensione di età, poiché le aree montane coincidono in larga misura con quelle a più elevato invecchiamento.

B.5 I servizi e i flussi

Il contesto di servizio in cui il Servizio di Psicologia di Base si inserirebbe è quello di un sistema sanitario di eccellenza, finanziariamente solido e attrattore netto di pazienti. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale è dell'ordine di undici miliardi di euro, con conti in equilibrio e nessun piano di rientro.^[837] Il saldo della mobilità sanitaria è strutturalmente attivo, dell'ordine di quasi duecento milioni di euro, e colloca il Veneto al terzo posto nazionale: essendo la regione creditrice, il canale del recupero della mobilità passiva — rilevante per la Puglia — non si applica, e ciò incide sulla composizione del caso economico.^[838] L'architettura dei servizi è imperniata su nove Aziende ULSS di grandi dimensioni, sull'Azienda Zero e sulle Aziende Ospedaliere universitarie, con la rete delle Case di Comunità in costruzione.^[839] La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per il Veneto
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	~ 11 miliardi di euro; conti in equilibrio; nessun piano di rientro
Mobilità sanitaria attiva	saldo +198 milioni di euro (regione creditrice, terza d'Italia; canale non applicabile)
Accessi al pronto soccorso	~ 1.500.000 l'anno
Architettura dei servizi	Nove ULSS, Azienda Zero, due Aziende Ospedaliere, IOV; Case di Comunità in costruzione
Margine di azione principale	Liste di attesa, erosione degli organici, accesso delle aree montane

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca è, nel Veneto, peculiare e ricca. Sul piano regionale, la regione è stata l'apripista nazionale, avendo avviato la prima sperimentazione già nel 2014; il Consiglio regionale ha poi impegnato la Giunta, con la mozione n. 302 del 2022, ad avviare un servizio permanente di psicologia delle cure primarie collegato alle Case di Comunità; e sono in corso d'esame proposte di legge dedicate, mentre la cornice organizzativa di riferimento resta la legge regionale n. 19 del 2016, istitutiva dell'Azienda Zero.^[840] Sul piano nazionale, il Decreto Ministeriale 77 del 2022 ha fissato gli standard

dell’assistenza territoriale e il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanzia le Case di Comunità, mentre non esiste, allo stato, una legge nazionale che disciplini la figura dello psicologo di base. Questa cornice configura la decisione veneta non come l’introduzione di una funzione nuova, ma come la strutturazione e il dimensionamento di un servizio già sperimentato e già politicamente impegnato: è il presupposto da cui muovono i domini successivi, a partire dalla descrizione dell’intervento e del suo modello, oggetto della parte che segue.

Parte C — L’intervento e il suo modello

Definito il problema di salute, il bisogno e il contesto, questa parte descrive l’intervento e il suo modello: che cosa fa lo psicologo di base, secondo quale teoria del cambiamento (capitolo C.1), entro quale modello organizzativo (C.2), lungo quale percorso clinico e con quali esiti e garanzie di sicurezza (C.3), con quale sistema informativo (C.4), con quali strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5) e con quale impianto formativo (C.6). La descrizione è quella, comune a tutte le Regioni, del modello validato sulla Puglia, qui declinata sulle specificità venete: l’architettura centralizzata dell’Azienda Zero, la dualità fra pianura e aree montane, la presenza di un’esperienza sperimentale consolidata.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: una funzione dedicata all’intercettazione precoce del disagio, all’intervento breve e all’orientamento, e al filtro verso i servizi specialistici. Non è un servizio specialistico, né sostituisce i Dipartimenti di Salute Mentale: li precede e li alleggerisce, collocandosi a monte del sistema.^[841] Il modo in cui questa funzione produce valore è descritto da una teoria del cambiamento esplicita, che collega il bisogno agli esiti attraverso un meccanismo identificato.^[842] Il punto di partenza è un bisogno ampio e in larga parte non intercettato.^[843] La tabella seguente espone la catena, dal bisogno agli esiti.

Elemento della catena	Contenuto per il Veneto
Bisogno	~ 970.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Psicologo nelle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte e rete territoriale completata
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, particolarmente rilevante nella popolazione attiva, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell’intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo di base nelle Case di Comunità e nelle medicine di gruppo integrate, in collaborazione strutturata con i medici di medicina generale, secondo protocolli condivisi che definiscono l'accesso, la presa in carico e l'invio.^[844] L'organizzazione del servizio segue il principio dell'intensità crescente, che parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello.^[845] La specificità veneta risiede nel ruolo dell'Azienda Zero: ente di governo regionale con funzioni centralizzate di programmazione e acquisto, essa consente una progettazione unitaria del modello e un'attuazione omogenea ed efficiente sulle nove Aziende ULSS, evitando la frammentazione e realizzando economie di scala nella formazione, nell'acquisizione delle tecnologie e nella definizione dei protocolli. È un vantaggio che distingue il Veneto e che il modello assume come leva di implementazione.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso diretto del cittadino o la segnalazione da parte del medico di medicina generale, una valutazione iniziale, un ciclo di colloqui brevi e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti.^[846] Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi.^[847] Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti.^[848] Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie — primario, clinici secondari, di processo, di impatto e utilizzo — di cui la tabella seguente riporta gli indicatori. Gli esiti economici sono trattati nella Parte E.^[849]

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La misurabilità dell'intervento dipende da un sistema informativo adeguato. La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con il fascicolo sanitario elettronico regionale, consente il monitoraggio continuo, la valutazione degli esiti e l'alimentazione del disegno controfattuale.^[850] La completezza e la sistematicità della raccolta dei dati di processo e di esito non sono un adempimento accessorio, ma la condizione stessa della clausola valutativa: vanno previste fin dall'avvio del servizio.^[851] Anche in questo l'architettura veneta offre un vantaggio, poiché l'Azienda Zero è titolare di funzioni informative centralizzate e costituisce il riferimento naturale per un sistema di monitoraggio unitario su tutte le aziende.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono parte integrante del modello, ma in funzione rigorosamente ancillare e sotto costante sorveglianza umana. Concorrono al triage e allo screening assistiti, per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sempre sotto supervisione clinica.^[852] Forniscono supporto decisionale e sintesi clinica come ausilio non vincolante al professionista, che ne resta pienamente responsabile.^[853] Riducono il carico amministrativo mediante automazione appropriata, restituendo tempo alla cura.^[854] Nel Veneto, una funzione assume particolare rilievo: la telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti, che costituiscono lo strumento decisivo per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle aree montane del Bellunese e dell'Altopiano, complementare e non sostitutivo della presa in carico in presenza.^[855] Vi si aggiungono i dispositivi terapeutici digitali, interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici.^[856] La tabella seguente riepiloga strumenti, funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle aree montane (Bellunese, Altopiano); continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

L'efficacia del servizio dipende in misura decisiva dalle competenze dei professionisti, che il modello costruisce attraverso un programma formativo articolato su quattro livelli: universitario, post-universitario specialistico, continuo lavorativo e di affiancamento operativo.^[857] A questi si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli, dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità. Nel Veneto, il programma trova condizioni particolarmente favorevoli: le Università di Padova e Verona offrono una solida base formativa, e la centralizzazione delle funzioni di acquisto e formazione in capo all'Azienda Zero consente un'introduzione uniforme ed efficiente, candidando la regione a contesto esemplare a livello nazionale per l'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale.^[858] La tabella seguente descrive i quattro livelli e la componente trasversale. Definito l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza scientifica.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Università di Padova e Verona
2. Post-universitario specialistico	Psicologia di base e cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, percorsi clinici	Corso regionale con attestato
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

Parte D — L'efficacia e l'evidenza

Descritto l'intervento, questa parte ne accerta l'efficacia sulla base delle prove scientifiche. Espone il metodo e i risultati della revisione sistematica della letteratura (capitolo D.1), la qualità e la certezza dell'evidenza secondo i criteri riconosciuti (D.2), i benchmark internazionali e italiani che ne costituiscono il riferimento (D.3) e le condizioni di trasferibilità al contesto regionale (D.4). L'evidenza qui richiamata è, per sua natura, sovranazionale e comune a tutte le Regioni; la sua declinazione veneta riguarda la trasferibilità, su cui incide in modo specifico l'esperienza sperimentale che la regione ha maturato per prima in Italia.

D.1 La revisione sistematica

La sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con un sistema esplicito, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati.^[859] Il quadro che ne emerge è solido e convergente. Lo studio fondativo del modello collaborativo ha documentato un recupero a dodici mesi nettamente superiore alla cura usuale.^[860] Le meta-analisi successive hanno confermato un miglioramento medio dei sintomi depressivi clinicamente apprezzabile.^[861] Le revisioni delle implementazioni più recenti hanno quantificato riduzioni rilevanti non solo dei sintomi, ma anche degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri.^[862] I dati di esito reale del programma inglese, raccolti su scala di milioni di persone, mostrano tassi di recupero e di miglioramento affidabili e una completezza dei dati superiore al 98%.^[863] Una meta-analisi sulle cure integrate stima un effetto di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante su popolazione.^[864] La tabella seguente riepiloga i principali risultati.

Fonte	Risultato principale
Studio fondativo (JAMA, 2002)	~ 50% dei pazienti con riduzione $\geq 50\%$ dei sintomi a 12 mesi, contro 19% nella cura usuale
Meta-analisi su 57 studi (2012)	Miglioramento medio dei sintomi depressivi di 0,28 deviazioni standard
Revisione su 42 implementazioni (2024)	-47% depressione e -43% ansia a 6 mesi; -34% accessi al PS; -41% ricoveri
Programma inglese, dati reali (2023-2024)	Recupero 50,2%; miglioramento affidabile 67,8%; completezza dei dati > 98%
Meta-analisi sulle cure integrate	Coefficiente standardizzato -0,11 sui sintomi depressivi (clinicamente rilevante su popolazione)

Tabella D.1. Principali risultati della letteratura sull’**efficacia dell’integrazione psicologica** nelle cure primarie.

D.2 La qualità dell’evidenza

La fiducia nelle prove va graduata secondo la qualità metodologica. Applicando il sistema riconosciuto, la certezza dell’evidenza è da moderata a elevata per l’efficacia clinica dell’integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni, mentre è più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, in particolare quelli di sistema.^[865] Questa distinzione è metodologicamente decisiva e onestamente dichiarata: l’efficacia clinica è ben fondata, il ritorno economico richiede maggiore cautela. Lo studio fondativo, in particolare, non documenta risparmi statisticamente significativi sui costi sanitari diretti, ciò che conferma come il valore del modello risieda in misura preponderante nei ritorni sociali più che nei risparmi sanitari diretti — conclusione del tutto coerente con il profilo del caso economico veneto, esaminato nella Parte E.^[866]

D.3 I benchmark internazionali

L’esperienza internazionale offre modelli consolidati di riferimento. Il programma inglese delle terapie psicologiche è il termine di paragone principale per l’organizzazione a intensità crescente e per la cultura della misurazione sistematica degli esiti.^[867] Il modello olandese integra una figura di supporto psicologico nello studio del medico di base, ampiamente adottata e di ruolo complementare.^[868] L’iniziativa australiana, fondata sull’invio esterno, ha ampliato significativamente la quota di popolazione in trattamento.^[869] Il modello statunitense delle cure collaborative, validato da una vasta letteratura controllata, documenta riduzioni rilevanti della depressione e dei ricoveri.^[870] Le esperienze italiane, infine, anticipano il modello nelle cure primarie, pur derivando da campioni limitati.^[871] La tabella seguente confronta i programmi sul piano clinico e organizzativo; il confronto economico è sviluppato nella Parte E.

Programma	Assetto	Esiti clinici e organizzativi
Programma inglese (NHS Talking Therapies)	Integrato; intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio > 98%; > 1,3 mln/anno
Modello olandese (POH-GGZ)	Integrato nelle cure primarie	Adozione ~3/4 dei medici; ruolo complementare
Iniziativa australiana (Better Access)	Invio esterno	Trattamento dal 35% al 46%; elevata soddisfazione
Collaborative Care (Stati Uniti)	Équipe integrata	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione; -41% ricoveri
Esperienze italiane (Solano, Lazio)	Sperimentazione locale	Anticipazione del modello nelle cure primarie

Tabella D.2. I benchmark internazionali e italiani sul piano clinico e organizzativo (il confronto economico è nella Parte E).

D.4 La trasferibilità al contesto regionale

L'evidenza richiamata proviene da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale, e la sua trasposizione al Veneto richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche.^[872] Su questo terreno il Veneto presenta una condizione distintiva e favorevole: la regione è stata l'apripista nazionale, avendo avviato già nel 2014 una sperimentazione regionale di psicologia di base, e dispone pertanto di una base di evidenza locale di particolare valore, da analizzare e valorizzare sistematicamente nel disegno del servizio permanente.^[873] A ciò si aggiungono la solidità organizzativa del sistema e l'architettura centralizzata dell'Azienda Zero, che costituiscono un terreno favorevole all'adozione e alla valutazione rigorosa del modello.^[874] Va infine ribadita un'avvertenza che attraversa tutto lo studio: le formule sintetiche di ampia circolazione — il rapporto di quattro a uno, l'affermazione per cui un euro ne genererebbe dieci — sono semplificazioni divulgative; le stime fondate collocano il ritorno su valori più misurati, che lo studio adotta in via prudenziale.^[875] Accertata l'efficacia e definite le condizioni della sua trasferibilità, la parte che segue ne traduce le implicazioni sul piano economico.

Parte E — La valutazione economica

Accertata l'efficacia, questa parte ne misura il valore economico — il dominio centrale della valutazione e quello di maggiore interesse per le autorità di bilancio. Identifica e misura i costi (capitolo E.1) e gli esiti (E.2), ne deriva il costo-efficacia e il costo-utilità (E.3), ne valuta l'impatto sul bilancio sanitario (E.4) e il ritorno sociale per la collettività (E.5), e ne compone i risultati nel caso economico e nel caso finanziario (E.6). La trama dell'intera parte è la distinzione, mantenuta con rigore, tra il saldo diretto per il bilancio sanitario e le ricadute per la collettività: una distinzione che, nel caso veneto, è decisiva, poiché il valore dell'intervento risiede in misura preponderante nelle seconde.

E.1 L'identificazione e la misura dei costi

Il costo del servizio comprende le remunerazioni dei psicologi, i costi organizzativi e di coordinamento e la quota destinata alla formazione, ed è stimato per scenario di copertura.^[876] A regime, esso si colloca nell'ordine di 30 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 45 in quello base e 58 in quello espansivo.^[877] La stima

muove da un valore unitario per incarico dell'ordine di 55.000 euro annui, regionalizzato in proporzione alla popolazione e al numero di professionisti, con economie di scala rese possibili dalla centralizzazione delle funzioni di acquisto in capo all'Azienda Zero.^[878] La tabella seguente riporta il costo per scenario; la funzione è oggi sperimentata e impegnata, ma non ancora strutturata a regime, e per questo il costo attuale del servizio strutturato è prossimo a zero.

Scenario	Psicologi	Costo annuo (mln €)
Attuale (sperimentazioni e impegno)	Servizio non strutturato	~ 0
Conservativo	~ 530	~ 30
Base	~ 800	~ 45
Espansivo	~ 1.050	~ 58

Tabella E.1. Il costo del servizio per scenario di copertura. La funzione è oggi sperimentata e impegnata ma non ancora strutturata a regime.

E.2 L'identificazione e la misura degli esiti

Gli esiti di salute sono espressi in anni di vita ponderati per la qualità e in esiti clinici validati, applicati in via prudenziale a partire dai tassi di recupero e di miglioramento desunti dai benchmark consolidati.^[879] Le misure cliniche sono impiegate nei soli punteggi complessivi, con un tasso di recupero di riferimento dell'ordine del 50%, coerente con i dati di esito reale del programma inglese.^[880] La quantificazione degli esiti è il presupposto del costo-utilità, sviluppato nel capitolo che segue, e della modellazione per paziente della Parte F.

E.3 Il costo-efficacia e il costo-utilità

Il rapporto tra i costi e gli esiti di salute definisce il costo-efficacia e il costo-utilità. Il costo per anno di vita ponderato per la qualità si colloca al di sotto della soglia comunemente adottata nella valutazione economica in sanità, e l'analisi per paziente — sviluppata nella Parte F con i metodi della modellazione decisionale e della sensibilità probabilistica — indica condizioni di dominanza dell'intervento, ossia un esito migliore a un costo inferiore rispetto all'opzione di non intervento.^[881] La soglia di riferimento adottata è dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità.^[882] Va tuttavia tenuta distinta l'efficienza dell'intervento sul singolo paziente, robusta, dal saldo aggregato sul bilancio, che è altra grandezza ed è oggetto del capitolo seguente.

E.4 L'impatto sul bilancio

L'analisi di impatto sul bilancio misura l'effetto sulla spesa sanitaria regionale, esercizio per esercizio e su flussi non scontati. I risparmi diretti si articolano nei canali del pronto soccorso, della farmaceutica e dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche evitabili; il canale della mobilità recuperata è nullo, poiché il Veneto è regione a saldo di mobilità attivo.^[883] I risparmi diretti complessivi si collocano, in via prudenziale, nell'ordine di 18, 30 e 45 milioni di euro annui nei tre scenari.^[884] Posti a confronto con il costo del servizio, essi determinano un saldo diretto lievemente negativo, dell'ordine di -12, -15 e -13 milioni di euro annui.^[885] Questo risultato è

dichiarato senza attenuazioni: non è una debolezza dell'analisi, ma il suo profilo onesto, e rinvia al ritorno sociale la sede in cui il valore dell'intervento si manifesta.^[886] La tabella seguente espone i risparmi diretti per canale e il saldo diretto per scenario.

Canale (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Pronto soccorso	3	5	7
Farmaceutica	4	6	9
Ricoveri e specialistica	11	19	29
Mobilità recuperata	0	0	0
Risparmi diretti (totale)	~ 18	~ 30	~ 45
Costo del servizio	~ 30	~ 45	~ 58
Saldo diretto (solo SSR)	~ -12	~ -15	~ -13

Tabella E.2. I risparmi diretti per canale e il saldo diretto sul bilancio sanitario, per scenario. Il saldo diretto è lievemente negativo.

E.5 Il ritorno sociale

Il valore generato dall'intervento oltre il bilancio sanitario è misurato con i metodi del ritorno sociale sull'investimento. Le ricadute economico-sociali comprendono la maggiore produttività recuperata, la riduzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, le efficienze nel sistema dei servizi di salute mentale e il sollievo alle figure di cura familiari.^[887] Nel Veneto, regione a economia dinamica e a elevata occupazione, la componente della produttività recuperata connessa all'intercettazione precoce del disagio nella popolazione attiva è la voce di maggior peso del beneficio complessivo. Le ricadute sociali si collocano, con criteri conservativi, nell'ordine di 95, 180 e 280 milioni di euro annui nei tre scenari.^[888] Sommando le due componenti, il ritorno complessivo è dell'ordine di 113, 210 e 325 milioni di euro annui, e il saldo complessivo, al netto del costo, è dell'ordine di +83, +165 e +267 milioni di euro annui.^[889]

E.6 Il caso economico e il caso finanziario

La composizione dei risultati nel Five Case Model distingue due grandezze e due prospettive. Il caso finanziario, riferito al solo bilancio sanitario regionale, presenta un saldo diretto lievemente negativo: il servizio, sul piano della cassa sanitaria, non si autofinanzia. Il caso economico, riferito alla collettività, è ampiamente positivo, con un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,8:1 nello scenario conservativo, 4,7:1 in quello base e 5,6:1 in quello espansivo.^[890] La distinzione tra le due grandezze è la chiave dell'intera valutazione: l'investimento non si giustifica come misura di risparmio per la cassa sanitaria, ma come misura di valore per la collettività.^[891] Sul piano della sostenibilità, il costo del servizio si colloca nell'ordine dello 0,3-0,5% di un Fondo Sanitario Regionale di circa 11 miliardi di euro, importo pienamente sostenibile per un sistema solido e in equilibrio.^[892] Resta, e va ribadita, la lacuna prioritaria: le grandezze economiche qui impiegate sono in parte ricostruite per quota di popolazione e non estratte dai conti regionali

certificati, la cui verifica presso l’Azienda Zero e le Aziende ULSS è condizione per la presentazione alle autorità di finanza pubblica.^[893] La tabella seguente sintetizza il quadro economico per scenario. Definito il caso economico, la parte che segue ne esamina la robustezza per paziente e sotto incertezza.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Risparmi diretti (SSR)	~ 18	~ 30	~ 45
Ricadute economico-sociali	~ 95	~ 180	~ 280
Ritorno complessivo	~ 113	~ 210	~ 325
Costo del servizio	~ 30	~ 45	~ 58
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -12	~ -15	~ -13
Saldo complessivo (caso economico)	+83	+165	+267
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,8:1	~4,7:1	~5,6:1

Tabella E.3. Sintesi economica per scenario: il caso finanziario (saldo diretto negativo) e il caso economico (saldo complessivo positivo).

Parte F — Modellazione decisionale e incertezza

La valutazione economica della Parte E poggia su una proiezione di costi ed esiti nel tempo, e su un governo esplicito dell’incertezza che la circonda. Questa parte ne espone gli strumenti: la struttura del modello decisionale (capitolo F.1), i parametri e la loro calibrazione (F.2), l’analisi di sensibilità deterministica (F.3) e probabilistica con la curva di accettabilità (F.4) e il valore dell’informazione (F.5). I risultati del modello per paziente sono, per loro natura, indipendenti dalla regione, poiché descrivono il decorso clinico del disturbo e non il contesto; la loro declinazione veneta riguarda la riconciliazione con il saldo aggregato e le priorità di acquisizione dei dati.

F.1 La struttura del modello

L’analisi impiega un modello di Markov a coorte, strumento standard della valutazione economica in sanità, che rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi — sintomatico, recupero, cronico, morte — scanditi da cicli con correzione di metà ciclo.^{[894][895]} I risultati del caso base, per singolo paziente e su orizzonte quinquennale scontato, indicano che il braccio dell’intervento è a un tempo meno costoso e più efficace dell’assistenza usuale, configurando una condizione di dominanza.^[896] La dominanza non è un artificio, ma la conseguenza della struttura di costo del modello: l’intervento accresce il tempo trascorso nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce quello trascorso nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte.^[897] La tabella seguente riporta i risultati del caso base.

Caso base, per paziente	Intervento	Cura usuale	Differenza
Costo sanitario (5 anni, scontato)	~ 2.495 €	~ 3.799 €	– 1.304 €
Utilità (anni di vita ponderati)	3,627	3,392	+ 0,236
Esito	—	—	Dominanza (più efficace, meno costoso)

Tabella F.1. Risultati del caso base del modello di Markov, per paziente, su orizzonte quinquennale scontato.

F.2 I parametri e la calibrazione

La credibilità del modello dipende dai parametri che lo alimentano e dalle distribuzioni di probabilità a essi assegnate. La struttura di costo per ciclo — contenuta nello stato di recupero, elevata nello stato cronico, con un costo una tantum per l'intervento — è ciò che genera la dominanza, poiché lo stato che l'intervento riduce è di gran lunga il più oneroso.^[898] Alle grandezze incerte sono assegnate distribuzioni appropriate — Beta per le probabilità e le utilità, Gamma per i costi — con valori centrali tratti dall'evidenza internazionale e da calibrare, per i parametri regionali, sui valori veneti certificati non appena disponibili.^[899] La tabella seguente riporta i principali parametri e le distribuzioni assegnate.

Parametro	Valore	Distribuzione
Costo per ciclo — stato di recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — stato cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento psicologico (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione tra gli stati	da fonti, per braccio	Beta
Utilità associate agli stati	da fonti	Beta

Tabella F.2. Principali parametri del modello e distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

F.3 La sensibilità deterministica

Per saggiare la robustezza del risultato, ciascun parametro è fatto variare entro un intervallo plausibile, misurandone l'effetto sul beneficio monetario netto. L'analisi a una via, ordinata in un diagramma a tornado, individua i parametri più influenti — l'efficacia clinica, i tassi di ricaduta e di cronicizzazione, il costo dello stato cronico — senza che, entro gli intervalli esplorati, la convenienza dell'intervento per paziente venga ribaltata.^[900] Accanto all'incertezza dei parametri, l'incertezza sulla struttura e sulle assunzioni del modello è trattata mediante analisi di scenario, con validazione della coerenza interna ed esterna.^[901]

F.4 La sensibilità probabilistica e la curva di accettabilità

L'analisi probabilistica fa variare simultaneamente tutti i parametri, estraendoli a caso dalle rispettive distribuzioni per diecimila volte, così da propagarne l'incertezza sul risultato.^[902] Adottando la soglia di riferimento,^[903] la curva di accettabilità indica una probabilità dell'88,9% che l'intervento sia costo-efficace e

dell’84,6% che sia dominante, con un beneficio monetario netto medio di circa 7.815 euro per paziente.^[904] È qui necessario, per il Veneto, esplicitare la relazione tra questo risultato e il saldo aggregato della Parte E. La probabilità di costo-efficacia è una misura di efficienza riferita al singolo paziente, che valorizza il guadagno di salute e l’intera traiettoria di costo; il saldo diretto aggregato è invece negativo, perché il passaggio dal paziente all’aggregato regionale incorpora le correzioni per peso morto e per l’effettiva monetizzabilità dei costi evitati, e perché manca il canale della mobilità. L’efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali.^[905] La tabella seguente riepiloga i risultati dell’analisi probabilistica.

Misura dell’analisi probabilistica	Risultato
Iterazioni della simulazione Monte Carlo	10.000
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 €/QALY)	88,9%
Probabilità di dominanza	84,6%
Beneficio monetario netto medio	~ 7.815 € per paziente
Intervallo di credibilità al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 €

Tabella F.3. Risultati dell’analisi di sensibilità probabilistica (per paziente, soglia 30.000 €/QALY).

F.5 Il valore dell’informazione

L’incertezza residua non è soltanto da quantificare, ma da ridurre con priorità razionali. Il valore atteso dell’informazione perfetta misura il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l’incertezza, e la sua versione riferita ai singoli parametri indica quali sia prioritario misurare con precisione.^[906] Per il Veneto, i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso, non applicandosi il canale della mobilità — sono quelli su cui il valore dell’informazione è più elevato, e verso i quali va indirizzata prioritariamente la richiesta di dati certificati all’Azienda Zero.^[907] È anche il punto di raccordo con il monitoraggio: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le nove Aziende ULSS, oggetto della Parte L, riduce l’incertezza sostituendo progressivamente le stime con misure osservate sui dati veneti.^[908] Governata l’incertezza, la parte che segue affronta la dimensione distributiva ed equitativa dell’intervento.

Parte G — Equità e impatto distributivo

La valutazione economica misura il valore complessivo dell’intervento, ma non come esso si distribuisca tra i gruppi e i territori. Questa parte colma quel vuoto, trattando l’equità come dimensione costitutiva del valore: ne espone l’analisi (capitolo G.1), gli strumenti della costo-efficacia distributiva (G.2) e l’esame dei divari territoriali e dell’impoverimento (G.3). Nel Veneto la questione distributiva ha una fisionomia precisa, che la distingue dal Mezzogiorno: non un gradiente di deprivazione diffuso, ma la dualità fra la pianura e le aree montane, ed è su questa che l’analisi si concentra.

G.1 L'analisi di equità

La salute mentale presenta un gradiente sociale: le popolazioni svantaggiate ne soffrono di più e accedono meno ai servizi.^[909] In Veneto, tuttavia, dove il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato, il gradiente socio-economico non è il tratto distintivo: a prevalere è la dimensione territoriale dell'equità, ossia la dualità fra la pianura produttiva, densa e ben servita, e le aree montane del Bellunese e dell'Altopiano, anziane e in spopolamento.^[910] Il servizio agisce su questa disuguaglianza per la sua stessa natura: gratuito, di prossimità e privo di stigma, abbate le barriere che gravano di più sui più svantaggiati, e in Veneto in particolare la barriera geografica delle aree montane.^[911] Lo studio segue un insieme definito di variabili di equità, di accesso e di protezione finanziaria.^[912] La tabella seguente le riepiloga per dimensione.

Dimensione di equità	Variabili seguite dallo studio
Accesso	Tempi di attesa; accessibilità geografica nelle aree montane (Bellunese, Altopiano); contrasto all'erosione degli organici
Protezione finanziaria	Riduzione della spesa privata diretta; dell'impoverimento connesso alle cure; delle spese catastrofiche
Gruppi vulnerabili	Equità di genere; popolazioni straniere e fragili; persone con disabilità; barriere culturali e linguistiche; gratuità
Territorio	Riduzione del divario pianura-montagna; copertura del bisogno non soddisfatto

Tabella G.1. Le dimensioni dell'equità e le variabili seguite dallo studio.

G.2 La costo-efficacia distributiva

L'equità non è soltanto un principio, ma una grandezza misurabile. L'analisi costo-efficacia distributiva estende la valutazione economica alla dimensione distributiva, stimando come costi ed esiti si ripartiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l'effetto sulle disuguaglianze.^[913] La direzione del risultato è favorevole all'equità: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove oggi l'accesso è più difficile, i benefici si concentrano sui gruppi più svantaggiati, riducendo il gradiente territoriale negli esiti.^[914] L'attribuzione di pesi maggiori ai benefici dei più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia il rapporto beneficio-costi non ponderato, scelta tanto più prudente in una regione non prevalentemente deprivata.^[915] Il meccanismo operativo dell'equità è l'algoritmo allocativo, che distribuisce gli incarichi ponderando i territori per età, deprivazione e cronicità.^{[916][917]} La tabella seguente descrive gli strumenti impiegati.

Strumento della costo-efficacia distributiva	Che cosa misura
Anni di vita ponderati per l'equità	Guadagni di salute con pesi per lo svantaggio
Indice di concentrazione	Relazione tra esito di salute e posizione socio-economica
Indici di disuguaglianza (assoluta e relativa)	Gradiente dell'esito lungo lo stato socio-economico
Valutazione d'*****impatto sull'*****equità	Distribuzione degli effetti per gruppi vulnerabili e per area
Indice di deprivazione multipla	Reddito, occupazione, istruzione, salute, abitare, ambiente

Tabella G.2. Gli strumenti della costo-efficacia distributiva e dell'analisi di equità.

G.3 I divari territoriali e l'impoverimento

La dimensione territoriale è, nel Veneto, il cuore della questione distributiva. Il divario rilevante non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra la pianura densa e produttiva e le aree montane del Bellunese e dell'Altopiano, a popolazione anziana e dispersa, dove il Bellunese è la provincia più anziana e l'unica con mortalità in crescita; in queste aree la sola presenza di un primo livello accessibile, integrata dalla telepsicologia, costituisce già un atto di riequilibrio.^[918] A ciò si aggiunge una seconda leva distributiva, propria del Veneto: poiché il canale della mobilità recuperata non si applica, essendo la regione creditrice, la principale leva diviene la riduzione delle liste di attesa, il contrasto all'erosione degli organici dei servizi di salute mentale e il completamento della rete territoriale, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato.^[919] Sul versante della protezione finanziaria, il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata e l'impoverimento connesso alle cure, a vantaggio dei redditi bassi.^[920] E la copertura stessa del bisogno inevaso — dell'ordine di 970.000 persone — è un atto di equità, perché raggiunge chi meno accede spontaneamente.^[921] Tutte queste dimensioni sono seguite nel tempo dagli indicatori di equità del sistema di monitoraggio della Parte L.^[922] Definito il profilo distributivo, la parte che segue affronta i profili etico, giuridico e organizzativo.

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Oltre ai piani clinico, economico e distributivo, la valutazione deve accertare che l'intervento sia eticamente fondato, giuridicamente legittimo e organizzativamente conforme. Questa parte ne tratta i tre profili: quello etico (capitolo H.1), quello giuridico e costituzionale (H.2) e quello organizzativo e di conformità, segnatamente in materia di intelligenza artificiale e protezione dei dati (H.3). Il profilo giuridico assume, nel Veneto, una configurazione peculiare, poiché la decisione si colloca non a valle di una legge dedicata, ma a valle di una consolidata sperimentazione e di un impegno politico formale.

H.1 Il profilo etico

Sul piano etico, le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, già trattata, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato.^{[923][924]} Il consenso è modulare, prestato distintamente per i diversi trattamenti e reso anche in forma digitale; trattandosi di dati ultrasensibili, la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi vi acceda.^[925] La valutazione stessa è condotta secondo criteri etici: gli esiti sono resi pubblici indipendentemente dal loro segno, a garanzia

contro la selezione dei risultati favorevoli, e l’impianto è sottoposto al comitato etico competente.^[926] Una cautela specifica presiede alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili, con gli strumenti di esito impiegati nei soli punteggi complessivi e le situazioni di rischio indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza.^[927]

H.2 I profili giuridici e costituzionali

La legittimità dell’intervento poggia su una cornice costituzionale e legislativa solida. L’articolo 32 della Costituzione e la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale fondano la salute come diritto e il servizio su universalità ed equità.^[928] Il riparto di competenze colloca la tutela della salute tra le materie concorrenti, con i principi allo Stato e l’organizzazione alle Regioni: è entro questa competenza organizzativa che operano legittimamente gli atti regionali veneti.^[929] La determinazione dei livelli essenziali resta competenza esclusiva statale, leva di un’eventuale uniformazione nazionale.^[930] Di rilievo diretto è il precedente della Corte costituzionale che ha riconosciuto legittimo il modello regionale di psicologia di base.^[931] La base giuridica regionale veneta è peculiare: la sperimentazione del 2014, la mozione che impegna la Giunta al servizio permanente, le proposte di legge in corso d’esame e la legge istitutiva dell’Azienda Zero; la decisione verte sullo strutturare e dimensionare una funzione già sperimentata e impegnata.^[932] Quanto al vincolo di destinazione dei fondi sancito per le regioni in rientro, esso non si applica al Veneto, i cui conti sono in equilibrio.^[933] La tabella seguente riepiloga i riferimenti essenziali.

Riferimento giuridico	Contenuto rilevante
Articolo 32 Cost. e legge n. 833/1978	Salute come diritto; Servizio sanitario universale, eguale ed equo
Articolo 117, terzo comma, Cost.	Tutela della salute: competenza concorrente (principi allo Stato, organizzazione alle Regioni)
Articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.	Livelli essenziali delle prestazioni: competenza esclusiva statale
Mozione n. 302/2022 e L.R. n. 19/2016	Base regionale: impegno al servizio permanente; sperimentazioni dal 2014; Azienda Zero per l’attuazione
Corte costituzionale, sentenza n. 241/2021	Modello regionale di psicologia di base riconosciuto legittimo (precedente)
Corte costituzionale, sentenza n. 6/2026	Vincolo dei fondi ai livelli essenziali per le regioni in rientro (non applicabile al Veneto)

Tabella H.1. I riferimenti giuridici e costituzionali essenziali dell’intervento.

H.3 Il profilo organizzativo e la conformità

Sul piano organizzativo, l’intervento si innesta nelle strutture esistenti senza alterarne le responsabilità. Il servizio opera nel rispetto della deontologia professionale, sotto la vigilanza dell’Ordine degli Psicologi del Veneto.^[934] L’impiego dell’intelligenza artificiale non modifica le responsabilità cliniche: il medico resta garante della diagnosi, lo psicologo dell’intervento psicologico, e l’IA è assimilata a un dispositivo di supporto, sicché non si introduce una nuova figura, ma uno strumento al servizio di quelle esistenti.^[935] La conformità degli strumenti di IA è governata dal quadro europeo — regolamento sull’intelligenza artificiale, regolamento

sui dispositivi medici, regolamento sulla protezione dei dati — con supervisione umana, validazione periodica e monitoraggio dei bias.^[936] Per non generare nuove disuguaglianze sono previsti canali tradizionali paralleli, in particolare per le persone anziane delle aree montane, e il supporto multilingue.^[937] La protezione dei dati è assicurata da misure robuste di sicurezza e da un consenso modulare, in collaborazione con l’Autorità garante.^[938] La tabella seguente riepiloga il quadro della conformità. Completati i profili etico, giuridico e organizzativo, la parte che segue affronta l’attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

Ambito	Riferimento	Garanzia
Deontologia	Ordine degli Psicologi del Veneto	Rispetto delle norme deontologiche; concorso alla governance
Responsabilità clinica	Medico e psicologo	Ruoli invariati; l’IA è strumento di supporto
IA e dispositivi	AI Act, dispositivi medici, protezione dei dati	Marcatura CE; supervisione umana; validazione periodica
Governance dell’IA	Comitato etico-scientifico	Monitoraggio dei bias; trasparenza; non discriminazione
Equità digitale	Canali paralleli; supporto multilingue	Alternativa in presenza sempre garantita
Protezione dei dati	Crittografia; pseudonimizzazione	Consenso modulare; collaborazione con il Garante

Tabella H.2. Il quadro della conformità organizzativa e di governance dell’intervento.

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Un intervento efficace ed economicamente fondato resta privo di effetto se non è attuabile. Questa parte ne affronta l’attuazione: la scienza dell’implementazione che ne guida il dispiegamento (capitolo I.1), il disegno del dispiegamento scaglionato (I.2), il caso commerciale del modello contrattuale e della tariffa (I.3), il caso gestionale della governance e dei rischi (I.4) e la sostenibilità finanziaria con le relative coperture (I.5). Il Veneto presenta qui due vantaggi distintivi: l’architettura centralizzata dell’Azienda Zero, che consente un’attuazione unitaria ed efficiente sulle nove Aziende ULSS, e una solidità finanziaria che rende la copertura agevolmente sostenibile.

I.1 La scienza dell’implementazione

L’attuazione non è lasciata all’improvvisazione, ma guidata dalla scienza dell’implementazione, che offre quadri per misurarne la riuscita e per comprenderne i determinanti.^[939] Il modello RE-AIM misura la riuscita lungo cinque dimensioni — portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento.^[940] Il quadro consolidato per la ricerca sull’implementazione ne spiega i determinanti, consentendo di individuare in anticipo barriere e facilitatori.^[941] Lo studio segue un insieme definito di determinanti dell’attuazione.^[942] La tabella seguente riepiloga i due quadri.

Dimensione	Che cosa misura o spiega
Portata (RE-AIM)	Quota della popolazione bersaglio raggiunta
Efficacia (RE-AIM)	Esiti clinici e di sistema effettivamente conseguiti
Adozione (RE-AIM)	Adesione delle sedi e dei professionisti
Implementazione (RE-AIM)	Fedeltà al modello e qualità dell'attuazione
Mantenimento (RE-AIM)	Sostenibilità del servizio nel tempo
Determinanti (quadro CFIR)	Innovazione, contesto esterno e interno, individui, processo

Tabella I.1. I quadri della scienza dell'implementazione: RE-AIM per gli esiti, CFIR per i determinanti.

I.2 Il disegno del dispiegamento

Il servizio non è attivato ovunque simultaneamente, ma per fasi: le nove Aziende ULSS passano in sequenza, per fasi semestrali, dalla condizione di controllo a quella di intervento, a partire dalle aziende di maggiore dimensione e prontezza, sino a coprire l'intera regione, secondo un ordine definito dalla Giunta su criteri trasparenti e con il coordinamento unitario dell'Azienda Zero.^[943] Questo disegno ha una doppia funzione: organizzativa, perché rende l'attivazione compatibile con i tempi del reclutamento e della formazione; e valutativa, perché la successione configura un esperimento naturale, fondamento della valutazione controfattuale della Parte L.^[944] Il reclutamento, a fronte di un fabbisogno a regime dell'ordine di 1.050 psicologi, avviene tramite elenco aziendale e rapporto convenzionale, valorizzando in prima applicazione l'esperienza maturata nelle sperimentazioni avviate dal 2014.^{[945][946]} Tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% nella fase di attuazione, che il monitoraggio è chiamato a verificare sui dati veneti.^[947] La tabella seguente descrive le fasi del dispiegamento.

Fase del dispiegamento	Contenuto
Fase 1 (primo semestre)	Avvio nelle Aziende ULSS di maggiore dimensione e prontezza; reclutamento e formazione iniziali
Fasi 2-9 (semestri successivi)	Estensione progressiva alle altre Aziende ULSS; attivazione scaglionata secondo l'ordine definito
Fase finale (completamento)	Copertura dell'intero territorio regionale
Attività trasversale	Monitoraggio e valutazione, che proseguono oltre il completamento del dispiegamento

Tabella I.2. Le fasi del dispiegamento scaglionato del servizio tra le nove Aziende ULSS.

I.3 Il caso commerciale: il modello contrattuale e la tariffa

Il caso commerciale del Five Case Model verifica la fattibilità dell'assetto contrattuale. Esso poggia su un rapporto convenzionale ancorato all'accordo della specialistica ambulatoriale, da cui discende un costo medio per incarico dell'ordine di 55.000 euro l'anno e gli scenari di spesa già esposti nella Parte E.^[948] Il modello dell'elenco aziendale e del rapporto convenzionale è già adottato da altre Regioni e non richiede la creazione di nuove figure professionali, ma l'impiego di quelle esistenti entro una cornice organizzativa definita. È una soluzione collaudata, che riduce il rischio attuativo e che la regia centralizzata dell'Azienda Zero può rendere ancora più efficiente in fase di acquisizione.

I.4 Il caso gestionale: la governance e i rischi

Il caso gestionale definisce la governance dell'attuazione, articolata su due livelli. A livello regionale, un comitato di indirizzo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, l'Azienda Zero, le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere universitarie, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, la medicina generale, la pediatria di libera scelta e le università di Padova e Verona; a livello aziendale, ciascuna Azienda ULSS è responsabile dell'attuazione nel proprio ambito, secondo la regia unitaria dell'Azienda Zero.^[949] L'attuazione è esposta a rischi che lo studio individua e a cui associa misure di mitigazione.^[950] La tabella seguente li riepiloga.

Rischio	Natura	Misura di mitigazione
Reclutamento insufficiente	Carenza di psicologi formati	Dispiegamento graduale; formazione anticipata e scaglionata
Adesione della medicina generale	Integrazione debole nel percorso	Protocolli di invio; formazione congiunta; governance condivisa
Sistemi informativi	Interoperabilità incompleta	Cartella interoperabile; standard nazionali; raccordo con l'Azienda Zero
Disomogeneità territoriale	Attuazione diseguale tra Aziende ULSS	Algoritmo allocativo; indirizzo regionale; monitoraggio per area
Venir meno delle coperture	Fragilità finanziaria	Istituzionalizzazione; copertura ordinaria su bilancio in equilibrio

Tabella I.3. I rischi attuativi e le relative misure di mitigazione.

I.5 La sostenibilità finanziaria e le coperture

La sostenibilità finanziaria è, nel Veneto, particolarmente solida. Le fonti di copertura comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali.^[951] A differenza delle regioni in difficoltà, il Veneto dispone di un finanziamento dell'ordine di 11 miliardi di euro con conti in equilibrio e non è in piano di rientro; il costo del servizio, anche a massima copertura, ne costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale, agevolmente assorbibile.^[952] La sostenibilità nel tempo è garantita dalla modestia del costo, dal forte ritorno sociale e dall'istituzionalizzazione del servizio, già oggetto di impegno politico formale.^[953] Resta ferma la cautela metodologica che attraversa lo studio: i dati italiani disponibili sono in parte di

letteratura grigia, e la verifica empirica sui dati veneti, prevista dalla Parte L, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate.^[954] Definite l’attuazione e la sostenibilità, la parte che segue ne organizza il monitoraggio e la valutazione ex post.

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Le stime delle parti precedenti sono proiezioni: per trasformarle in prove occorre misurare l’intervento nel tempo. Questa parte organizza tale misurazione: il sistema di indicatori (capitolo L.1), il protocollo di rilevazione e la costituzione della baseline (L.2), la valutazione controfattuale d’impatto (L.3), la verifica ex post della norma (L.4) e gli indicatori compositi con il cruscotto regionale (L.5). Il disegno scaglionato del dispiegamento sulle nove Aziende ULSS, descritto nella Parte I, è qui la risorsa decisiva, poiché trasforma l’attuazione graduale in un esperimento naturale che consente di misurare l’effetto causale della riforma sui dati veneti.

L.1 Il sistema di indicatori

La misurazione poggia su un sistema strutturato di indicatori, costruito secondo il modello classico della qualità dell’assistenza, che distingue struttura, processo ed esito, qui integrato dalla dimensione dell’impatto.^{[955][956]} La batteria comprende circa cinquantotto misure articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti e circa quaranta richiedono la rilevazione diretta del servizio.^[957] La selezione degli esiti segue i criteri del consenso strutturato, per evitare la proliferazione di misure ridondanti.^[958] Tra le misure di equità figurano i divari tra le Aziende ULSS.^[959] La tabella seguente riepiloga le categorie e lo stato della baseline.

Categoria	Esempi di indicatori	Baseline
Bisogno e domanda	Prevalenza del disagio, utenza dei servizi, accessi impropri	Disponibile
Accesso ed equità	Tempo di attesa, copertura, divari tra Aziende ULSS	Da rilevare
Processo	Sedute erogate, cicli completati, abbandoni	Da rilevare
Esito clinico	Recupero, miglioramento affidabile, mantenimento	Da rilevare
Economici	Risparmi per canale, costo per esito	Misto
Impatto sociale	Produttività, benessere, indicatori territoriali	Misto
Organizzativi	Reclutamento, formazione, fedeltà al modello	Da rilevare
Variabili di sintesi	Indici compositi di esito e di valore	Da calcolare

Tabella L.1. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline. Circa quaranta indicatori richiedono la rilevazione diretta del servizio.

L.2 Il protocollo di rilevazione e la baseline

La rilevazione si fonda su un protocollo minimo, attivo dal primo giorno, che registra la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni, deliberatamente essenziale per non gravare sull'attività clinica.^[960] Gli strumenti di esito sono i questionari validati, impiegati nei soli punteggi complessivi.^[961] La raccolta a ogni seduta, e non solo all'inizio e alla fine, consente di calcolare il tasso di recupero e di non protrarre percorsi inefficaci.^[962] La baseline si costituisce su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti vanno registrati subito, mentre la rilevazione di servizio parte con il primo assistito; ogni mese di ritardo nell'avvio è un mese di dati di base perduti.^[963] Il calendario della rilevazione scandisce le fasi, dal momento precedente l'avvio alla trasmissione periodica degli indicatori al comitato di indirizzo regionale.^[964] La tabella seguente lo riporta.

Momento	Attività
Prima dell'avvio (per area)	Costituzione della baseline con i dati disponibili; predisposizione del registro e dei questionari
All'avvio	Inizio della registrazione di ogni presa in carico e di ogni seduta, con i punteggi di esito
In continuo	Alimentazione del registro; trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale con cadenza mensile
Periodico (semestrale e annuale)	Calcolo delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale

Tabella L.2. Il calendario della rilevazione. La baseline da statistiche correnti precede l'avvio; la rilevazione di servizio parte con il primo assistito.

L.3 La valutazione controfattuale

Il cuore metodologico della valutazione ex post è la stima dell'effetto causale della riforma, ossia il confronto tra gli esiti dei trattati e ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente.^[965] Lo strumento che la rende possibile è il disegno scaglionato del dispiegamento: la differenza-nelle-differenze confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le Aziende ULSS già attivate e quelle non ancora attivate, affiancata dal controllo sintetico.^[966] L'analisi restituisce l'effetto medio sulla popolazione e sui soli trattati, secondo lo strumento raccomandato dalla letteratura per gli interventi di salute della popolazione.^[967] È così che, confrontando ad esempio l'andamento degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche tra le aziende che hanno attivato il servizio e quelle che lo attiveranno, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasformano le stime dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata sui dati veneti.^[968]

L.4 La verifica ex post della norma

Alla valutazione d'impatto si affianca la verifica ex post della norma, prevista dall'ordinamento: è la valutazione, di norma dopo un biennio, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, che chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione.^[969] Il raccordo con la responsabilità politica è assicurato dalla clausola valutativa, che impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati: nel Veneto questo passaggio è già prefigurato dalla mozione n. 302 del 2022, ed è ciò che lega la misurazione tecnica alla trasparenza verso il legislatore.^[970]

L.5 Gli indicatori compositi e il cruscotto

La pluralità degli indicatori è ricondotta a sintesi mediante indici compositi, costruiti secondo i criteri metodologici riconosciuti.^[971] L'impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica ha già un precedente istituzionale consolidato.^[972] La costruzione degli indici rispetta le regole di coerenza e il divieto di doppia contabilizzazione, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali.^[973] Gli indici alimentano un cruscotto regionale che restituisce, in forma sintetica e periodicamente aggiornata, le dimensioni essenziali del valore generato. La tabella seguente ne descrive le dimensioni di sintesi. Completato il monitoraggio, la parte conclusiva compone la sintesi multidimensionale e le raccomandazioni.

Dimensione di sintesi	Contenuto
Guadagno di salute	Anni di vita ponderati per la qualità in salute mentale
Tasso di recupero	Miglioramento clinico e superamento delle soglie (PHQ-9, GAD-7)
Ritorno sociale	Valore sociale generato per euro investito (SROI)
Equità territoriale	Esito e accesso tra Aziende ULSS e tra pianura e aree montane
Liste di attesa	Riduzione dei tempi di attesa e completamento della rete territoriale
Indicatori di sistema	Esito, esperienza, costo e operatori (Quadruple Aim)

Tabella L.3. Le dimensioni di sintesi del cruscotto regionale veneto.

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Le parti precedenti hanno esaminato l'intervento sotto i singoli profili — il bisogno, il modello, l'efficacia, l'economia, l'incertezza, l'equità, l'etica, l'attuazione, il monitoraggio. Questa parte conclusiva li ricompone in un giudizio unitario: applica la griglia di valutazione che attraversa l'intero studio (capitolo M.1), ne sintetizza il bilanciamento con l'analisi multi-criterio (M.2), trae la sintesi del valore e le raccomandazioni (M.3) e dichiara i limiti e l'agenda di ricerca (M.4). È qui che la natura particolare della decisione veneta si fa esplicita: non se prevedere il servizio, già sperimentato e impegnato, ma come strutturarlo e dimensionarlo.

M.1 La griglia di valutazione OCSE-DAC

Il giudizio complessivo si articola secondo i sei criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità — che, applicati congiuntamente, restituiscono un quadro d'insieme dell'intervento e ne costituiscono il caso strategico.^{[974][975]} Lungo questi criteri l'intervento riceve un giudizio largamente positivo: risponde a un bisogno reale e di grande dimensione, è coerente con il quadro normativo e programmatico, è efficace secondo l'evidenza internazionale, è efficiente in termini di costo-utilità ancorché a fronte di un saldo diretto negativo, ha un impatto distributivo favorevole ed è sostenibile.^{[976][977][978][979][980][981]} La tabella seguente riporta il giudizio criterio per criterio.

Criterio	Domanda valutativa	Giudizio dallo studio
Rilevanza	Risponde al bisogno reale?	Sì: ~970.000 con disagio inevaso; obbligo dei livelli essenziali
Coerenza	È compatibile con le altre politiche?	Sì: DM 77, PNRR, mozione 302/2022 e L.R. 19/2016; difendibile in Costituzione; nessun rientro
Efficacia	Raggiunge gli obiettivi?	Sì: evidenza internazionale (recupero ~50%)
Efficienza	Impiega le risorse in modo proporzionato?	Sì in costo-utilità (dominanza); saldo diretto negativo a costo modesto
Impatto	Produce effetti più ampi?	Sì: riduce il gradiente territoriale pianura-montagna; ritorno complessivo 3,8-5,6:1
Sostenibilità	I benefici e il servizio durano?	Sì: costo modesto, bilancio in equilibrio, istituzionalizzazione

Tabella M.1. La griglia di giudizio OCSE-DAC applicata allo studio, criterio per criterio.

M.2 L'analisi multi-criterio

Non tutti i criteri sono riducibili a denaro: l'equità, la fattibilità, la coerenza strategica e la robustezza dell'evidenza richiedono un bilanciamento esplicito. L'analisi multi-criterio lo rende trasparente, attribuendo a ciascun criterio un peso e a ciascuna opzione un punteggio.^[982] Il confronto tra l'opzione di intervento e l'opzione zero è netto: su otto criteri pesati, l'intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 80,7 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri tranne la fattibilità immediata, dove l'opzione zero — non fare nulla — è per definizione più agevole; il risultato è stabile rispetto ai pesi adottati.^[983] La tabella seguente riporta il confronto.

Criterio	Peso	Interv.	Opz. zero	Δ pond.
Efficacia clinica	15%	80	30	+7,5
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	88	25	+12,6
Impatto di bilancio e sostenibilità	15%	70	50	+3,0
Equità e accesso (aree montane, liste di attesa)	15%	85	20	+9,75
Valore sociale	10%	88	20	+6,8
Fattibilità e implementabilità	10%	70	100	-3,0
Robustezza dell'evidenza	10%	75	60	+1,5
Coerenza strategica (DM 77, PNRR, mozione 302/2022)	5%	90	25	+3,25
Punteggio complessivo ponderato	100%	80,7	39,25	+41,45

*Tabella M.2. Analisi multi-criterio: confronto tra l'*****opzione di intervento e l'*****opzione zero su otto criteri pesati.*

M.3 La sintesi del valore e le raccomandazioni

La sintesi del valore può essere condensata in tre affermazioni, che costituiscono il cruscotto decisionale per il Veneto: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, trascurabile rispetto a un finanziamento di 11 miliardi; il ritorno per la collettività è ampio, dell'ordine di 3,8-5,6 a uno; e tale valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali, segnatamente sulla produttività recuperata in una regione ad alta occupazione.^[984] Da qui discende la raccomandazione centrale, che ha nel Veneto una fisionomia peculiare: la decisione rilevante non è se prevedere il servizio — già sperimentato dal 2014 e oggetto dell'impegno assunto dal Consiglio con la mozione n. 302 del 2022 — ma se strutturarne e dimensionarlo, portandolo dalla sperimentazione alla copertura del fabbisogno, dell'ordine di 1.050 incarichi.^[985] La lettura del valore lungo le cinque dimensioni dell'esito, dell'esperienza, del costo, del benessere degli operatori e dell'equità conferma la coerenza del giudizio.^[986]

M.4 I limiti e l'agenda di ricerca

La trasparenza impone di dichiarare i limiti dello studio. Il principale attiene al radicamento nei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione veneta, e non estratte dai conti regionali certificati dell'Azienda Zero e delle Aziende ULSS; la loro sostituzione con dati certificati è la condizione per la presentazione agli organi di controllo.^[987] A ciò si aggiungono le cautele di trasferibilità e di fonte già segnalate — la parziale provenienza da letteratura grigia, la necessità di adattare i benchmark esteri, la natura prudentiale e non ponderata della cifra del ritorno.^[988] Ne discende un'agenda di ricerca dalle priorità definite: l'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso l'Azienda Zero e le Aziende ULSS, seguito dall'avvio della rilevazione di servizio e dalla valutazione controfattuale sul dispiegamento scaglionato.^[989] Con questa sintesi e con la dichiarazione dei suoi limiti lo studio si chiude, consegnando al decisore un quadro completo, onesto e fondato su cui deliberare; il corredo documentale prosegue nelle appendici tecniche.

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l'orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità.^[990] La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Servizio attuale o assenza del servizio a regime
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Azienda ULSS/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudentiale	Riduzione per l'ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura.^[991] La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato del Veneto, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.^[992] La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 530	~ 800	~ 1.050
Costo del servizio	~ 30	~ 45	~ 58
Risparmi diretti (SSR)	~ 18	~ 30	~ 45
Ricadute economico-sociali	~ 95	~ 180	~ 280
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -12	~ -15	~ -13
Saldo complessivo (caso economico)	+83	+165	+267
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,8:1	~4,7:1	~5,6:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell'esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario.^[993] La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura.^[994] La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori veneti impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.^[995]

Ambito	Valore regionale
Popolazione regionale	4.853.472 abitanti (Censimento ISTAT 2024); quarta regione d'Italia
Finanziamento del SSR	~ 11 miliardi di euro; conti in equilibrio; nessun piano di rientro
Mobilità sanitaria	Saldo attivo, dell'ordine di +198 milioni; regione creditrice, terza d'Italia
Pronto soccorso	~ 1,5 milioni di accessi/anno
Farmaceutica	Consumo regionale delle categorie dei psicofarmaci
Salute mentale	~ 970.000 con disagio comune; ~ 72.000 in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale
Funzione attuale	Sperimentazioni dal 2014; mozione n. 302/2022; funzione non ancora strutturata; ~ 5% del fabbisogno

Tabella C.1. I valori regionali di ancoraggio del Veneto.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione veneta, e non estratti dai conti regionali certificati.^[996] La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Azienda ULSS e per area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[997] La tabella seguente li riepiloga.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.^[998] Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra trattati e non trattati
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità non trattate
Dispiegamento scaglionato	Attivazione progressiva che rende le aree non ancora coperte gruppo di confronto

Termine	Definizione
Analisi e verifica d’impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta a riferire al Consiglio sui risultati della riforma
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell’implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall’impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d’ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l’intensità dell’intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; in Veneto il saldo è attivo
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di concentrazione	Misura che lega l’esito di salute alla posizione socio-economica
Peso morto	Quota dell’esito che si sarebbe verificata anche senza l’intervento

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

Friuli-Venezia Giulia — Studio HTA (parziale, Parti A–C)

Studio Integrale Regionale · Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dal Dipartimento sperimentale alla strutturazione a regime. Applicazione del telaio integrato — Parti A-C (quadro e metodo; bisogno e contesto; intervento e modello). Studio in corso di completamento (Parti D-M in lavorazione).

Indice

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per il Friuli-Venezia Giulia, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all’Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria, al Lazio, alla Campania, alla Sicilia, alla Sardegna e al Trentino-Alto Adige. L’architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati al Friuli-Venezia Giulia. Nell’architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l’impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l’analisi procede (capitolo A.3). Il Friuli-Venezia Giulia occupa nella serie una posizione propria: il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità, nel 2022, una mozione che impegna a istituire il servizio nelle Case della Comunità, e una sperimentazione è in avvio, ma non esiste ancora una legge attuativa, sicché la valutazione non riguarda l’opportunità di introdurre il servizio, già condiviso, ma la sua strutturazione in un modello pieno e il passaggio a regime.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il servizio di psicologia delle cure primarie del Friuli-Venezia Giulia, inteso come strutturazione in un modello pieno e passaggio a regime di una funzione che la regione si è già impegnata a introdurre con una mozione consiliare unanime, e che è oggi in fase di sperimentazione.^[999] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sulla consolidazione e l’estensione del servizio. La premessa che orienta l’intero studio è che la decisione rilevante, per il Friuli-Venezia Giulia, non è introdurre il servizio, già condiviso e in sperimentazione, ma dargli forma piena e condurlo a regime, strutturandolo nei distretti delle tre aziende sanitarie regionali e dimensionandolo, dalla sperimentazione iniziale alla copertura sistematica del fabbisogno, entro l’autonomia di una regione a statuto speciale che si autofinanzia la sanità tramite compartecipazione ai tributi erariali e registra finanze solide e nessun piano di rientro.^[1000] Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala. Va segnalato sin d’ora che la sperimentazione iniziale si colloca al di sotto dello stesso scenario conservativo qui considerato, che rappresenta invece il regime verso la copertura piena.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell’ordine di 239.000 persone, si somma un’utenza specialistica in carico ai servizi, in un quadro segnato da componenti convergenti — il bisogno dell’età anziana e della cronicità, prevalente in una delle regioni più anziane d’Italia, accentuato nelle aree montane e interne; il disagio giovanile e socio-economico nei centri di Trieste, Udine e Pordenone; e la dimensione plurilingue propria di una regione di confine — cui si aggiungono i divari di accesso, la pressione delle liste di attesa e il bisogno non sempre intercettato della componente straniera.^[1001] La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l’efficacia clinica, l’impatto economico diretto e sociale, l’equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti del Friuli-Venezia Giulia con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall’intera popolazione per gli effetti di sistema. L’intervento è il servizio di psicologia delle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, condotto dalla sperimentazione alla piena operatività a regime. Il confronto è la condizione attuale, fatta di iniziative frammentarie e della sperimentazione in avvio. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I

tempi distinguono l’orizzonte pluriennale degli esiti dall’orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario del Friuli-Venezia Giulia, con le sue tre aziende sanitarie regionali, l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, gli istituti a rilievo nazionale (IRCCS Burlo Garofolo, CRO di Aviano), e la rete delle Case della Comunità in costruzione.^[1002] La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per il Friuli-Venezia Giulia
Popolazione	Residenti sardi con disagio psichico comune (~239.000); in seconda istanza l’intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Servizio di psicologia delle cure primarie negli ambulatori delle Case della Comunità, primo livello e filtro, condotto a regime (~130/195/260 psicologi); dalla sperimentazione alla copertura sistematica
Confronto	Condizione attuale: impegno politico unanime (mozione 2022) e sperimentazione in avvio; servizio non ancora strutturato a regime né disciplinato da legge
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia; tre aziende sanitarie regionali, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), aziende ospedaliere, rete delle Case della Comunità in costruzione

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell’HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell’OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio.^[1003] In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l’intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l’insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e l’assetto attuale, fatto di iniziative frammentarie e della sperimentazione in avvio, come comparatore.^[1004] Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le tre aziende sanitarie regionali e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni, segnatamente fra i centri urbani di Trieste, Udine e Pordenone e le aree montane e interne della Carnia e delle valli.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale: iniziative frammentarie e sperimentazione in avvio, prima della strutturazione a regime
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per azienda sanitaria regionale e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso.^[1005] Tale prudenza assume, per il Friuli-Venezia Giulia, un rilievo particolare. Regione a statuto speciale, essa autofinanzia la sanità con risorse del proprio territorio attraverso la compartecipazione ai tributi erariali, senza concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario regionale; non è sottoposta a piano di rientro e presenta finanze solide. Sul versante della mobilità, la posizione di confine con Slovenia e Austria genera flussi nei due sensi, con un saldo contenuto, e non riguarda la domanda psicologica, sicché il canale del recupero è per questo intervento solo modestamente pertinente. Ne consegue un saldo diretto lievemente negativo ma modesto, agevolmente sostenibile entro l'autonomia finanziaria regionale, e il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi.^[1006] Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati; poiché il servizio è ancora in sperimentazione, il Friuli-Venezia Giulia dispone di una base di dati operativi propri limitata, e lo studio poggia per l'efficacia sui benchmark internazionali, mentre la sperimentazione in avvio costituirà la fonte primaria da consolidare.^[1007]

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post.^[1008] Per il Friuli-Venezia Giulia il disegno controfattuale assume una forma propria: poiché la strutturazione del modello pieno avverrà in tempi differenziati fra i distretti delle tre aziende sanitarie, essa può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, con l'ordine e i tempi di attivazione del servizio fra i distretti impiegati a fini valutativi e l'effetto causale stimato dai metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico.^[1009] La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, le tre aziende sanitarie regionali, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, gli istituti a rilievo nazionale (IRCCS Burlo Garofolo, CRO di Aviano), l'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei di Trieste e Udine. Il Friuli-Venezia Giulia dispone di un'azienda regionale di coordinamento per la salute e supporto tecnico-amministrativo, l'ARCS, accanto al coordinamento della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, e del Tavolo tecnico regionale interdisciplinare previsto dalla mozione del 2022.^[1010] Poiché il servizio è ancora in sperimentazione e la rete delle Case della Comunità è in costruzione, la sfida del governo non è introdurre il servizio, ma dargli forma piena e condurlo a regime, strutturandolo nei distretti delle tre aziende sanitarie e garantendo l'omogeneità attuativa nell'unico sistema sanitario regionale: è il tratto che distingue il Friuli-Venezia Giulia, e che la valutazione assume come punto di partenza.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza, con la piattaforma informativa sanitaria regionale quale infrastruttura per la raccolta uniforme.^[1011] Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici.^[1012] Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti.^[1013] Con

la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto del Friuli-Venezia Giulia.

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto del Friuli-Venezia Giulia. La struttura è quella già adottata per le altre regioni della serie, e mutano soltanto i dati, ancorati alla regione. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall’epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l’intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico del Friuli-Venezia Giulia: non un servizio da istituire, ma un servizio già condiviso da un impegno politico unanime e in fase di sperimentazione, da portare a forma piena e a regime in una regione di confine, fra le più anziane d’Italia, plurilingue, a statuto speciale e con finanze solide e nessun piano di rientro.

B.1 Quadro demografico

Il Friuli-Venezia Giulia conta 1.194.616 residenti, pari a circa il 2,0% della popolazione nazionale, sostanzialmente stabile per effetto di saldi migratori positivi che compensano un saldo naturale fortemente negativo e una natalità ai minimi storici.^[1014] La struttura per età è fra le più anziane d’Italia, con un’età media di 48,5 anni, la terza più elevata dopo Liguria e Sardegna, e un indice di vecchiaia di 244,1: l’invecchiamento è più accentuato nelle aree montane e interne della Carnia e delle valli.^[1015] La componente straniera, pari al 10,1%, è in linea con la media nazionale.^[1016] La distribuzione è concentrata sulle due province maggiori: Udine, con oltre 500.000 residenti, raccoglie il 43,3%, e Pordenone, con oltre 300.000, il 26,0% — insieme quasi il 70% — mentre Trieste e Gorizia ospitano il restante 30,7%.^{[1017][1018]} La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per il Friuli-Venezia Giulia
Popolazione (Censimento 2024)	1.194.616 (~2,0% del totale nazionale); sostanzialmente stabile, con saldi migratori positivi che compensano un saldo naturale negativo e una natalità ai minimi storici
Età media e struttura	~ 48,5 anni, terza più anziana d’Italia dopo Liguria e Sardegna; indice di vecchiaia 244,1; invecchiamento accentuato nelle aree montane e interne
Componente straniera	10,1% dei residenti (~120.000), in linea con la media nazionale; prevalenza rumena, albanese, bangladese
Distribuzione territoriale	Udine (oltre 500.000, 43,3%) e Pordenone (oltre 300.000, 26,0%) insieme ~70%; Trieste e Gorizia 30,7%; ~30% nei tre comuni >50.000 (Trieste, Udine, Pordenone)
Profilo territoriale	Centri urbani (Trieste, Udine, Pordenone) con disagio giovanile e socio-economico; aree montane e interne (Carnia, valli) anziane e in spopolamento; regione di confine e plurilingue
Articolazione sanitaria	Tre aziende sanitarie regionali (ASUGI, ASUFC, ASFO), Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), istituti a rilievo nazionale (IRCCS Burlo Garofolo, CRO di Aviano)

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico del Friuli-Venezia Giulia.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale nel Friuli-Venezia Giulia è ampio e sospinto da una struttura demografica fra le più anziane d'Italia, distribuita su un territorio di confine. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell'ordine di 239.000 persone, in larga parte non intercettate, tanto più in una fase in cui il servizio è ancora in avvio sperimentale.^[1019] A questa quota si somma un'ampia utenza specialistica in carico ai servizi, su un territorio che presenta una specificità propria: il consenso politico unanime espresso dalla mozione del 2022 e una sperimentazione in avvio.^[1020] Tre componenti orientano la domanda. La prima e più caratterizzante è il bisogno dell'età anziana e della cronicità, accentuato nelle aree montane e interne più anziane.^[1021] La seconda è il disagio giovanile e socio-economico nei centri di Trieste, Udine e Pordenone.^[1022] La terza è il disagio connesso allo spopolamento e all'isolamento delle aree montane e interne.^[1023] È la combinazione — regione di confine, molto anziana e plurilingue, con un consenso politico unanime ma un'attuazione ancora iniziale — a distinguere il fabbisogno regionale.^[1024] La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche significativi e resi più onerosi dalle distanze nelle aree montane.^[1025]

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone, nel Friuli-Venezia Giulia, un'offerta ancora in costruzione ma sostenuta da un forte consenso: il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, nel 2022, una mozione che impegna a istituire negli ambulatori delle Case della Comunità un primo livello di assistenza psicologica ad accesso diretto, per tutte le età, e nel 2026 una sperimentazione è stata aperta in linea con la normativa nazionale; la forma piena del servizio — inquadramento, dimensionamento e copertura — è ancora da definire in via legislativa.^[1026] Il fabbisogno a regime è stimato nell'ordine di 260 psicologi nello scenario espansivo, e l'Ordine professionale regionale, che da anni sollecita l'introduzione del servizio, ne sostiene la strutturazione.^[1027] La copertura attuale corrisponde dunque alla sola sperimentazione in avvio: non un servizio da introdurre, ma un servizio da strutturare nei distretti delle tre aziende sanitarie e da dimensionare.^[1028] La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per il Friuli-Venezia Giulia
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 239.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	Ampia (alcune decine di migliaia, stima rapportata ai dati nazionali)
Offerta territoriale attuale	Impegno politico unanime (mozione consiliare 2022): ambulatori nelle Case della Comunità, accesso diretto, tutte le età; sperimentazione aperta nel 2026; forma piena ancora da disciplinare
Fabbisogno stimato a regime	~ 260 psicologi nello scenario espansivo (130-195 negli altri scenari)
Copertura attuale del fabbisogno	Sperimentazione in avvio; servizio non ancora strutturato a regime né disciplinato da legge attuativa

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, nel Friuli-Venezia Giulia, si gioca su due assi. Il primo, territoriale, separa i centri urbani di Trieste, Udine e Pordenone dalle aree montane e interne della Carnia, del Friuli collinare e delle valli, più anziane, in spopolamento e penalizzate dalle distanze e dall'orografia. Il secondo, linguistico, attiene alla necessità che il servizio sia fruibile dalle comunità friulana, slovena e tedesca nella propria lingua.^[1029] Su questi divari il servizio agisce in funzione di equità: avvicina l'offerta alle aree montane e interne mediante la telepsicologia assistita — dove la sola presenza di un primo livello accessibile è già un atto di riequilibrio — e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica e contribuisce a contenere i tempi di attesa; collocato negli ambulatori delle Case della Comunità con accesso diretto, secondo l'impostazione della mozione del 2022, non oppone all'accesso delle fasce più fragili una barriera economica.

B.5 I servizi e i flussi

Il Servizio sanitario del Friuli-Venezia Giulia, in quanto regione a statuto speciale, si autofinanzia con risorse del proprio territorio attraverso la compartecipazione ai tributi erariali, senza che lo Stato concorra al finanziamento; non è sottoposto a piano di rientro e presenta finanze solide.^[1030] Il profilo di mobilità, in una regione di confine, genera flussi nei due sensi con Slovenia e Austria, con un saldo contenuto; poiché la mobilità non riguarda la domanda psicologica delle cure primarie, il canale del recupero è per questo intervento solo modestamente pertinente.^[1031] L'architettura dei servizi poggia su tre aziende sanitarie regionali (ASUGI, ASUFC, ASFO), sull'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute con funzioni di coordinamento, su istituti a rilievo nazionale, e su una rete territoriale di Case della Comunità in costruzione, negli ambulatori delle quali il servizio andrà innestato. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per il Friuli-Venezia Giulia
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	Statuto speciale, con autofinanziamento della sanità tramite compartecipazione ai tributi erariali, senza concorso dello Stato; nessun piano di rientro; finanze solide
Mobilità sanitaria	Regione di confine: flussi nei due sensi con Slovenia e Austria, saldo contenuto; non riguarda la domanda psicologica; canale modesto per questo intervento
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche significativi (alcune decine di migliaia l'anno, stima rapportata ai dati nazionali)
Architettura dei servizi	Tre aziende sanitarie regionali (ASUGI, ASUFC, ASFO), Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di coordinamento, istituti a rilievo nazionale; rete delle Case della Comunità in costruzione
Margine di azione principale	Strutturazione nei distretti delle tre aziende sanitarie, liste di attesa, accesso delle aree montane e interne, bisogno anziano e cronicità, dimensione linguistica, intercettazione precoce

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice segnata da un forte consenso politico: il Friuli-Venezia Giulia ha approvato all'unanimità, nel 2022, una mozione consiliare che impegna a istituire il servizio nelle Case della Comunità, e nel 2026 ha aperto una sperimentazione.^[1032] La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale, il quadro di tutela delle minoranze linguistiche (legge 482/1999 e legge 38/2001) e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera; sul piano regionale opera entro l'autonomia dello statuto speciale. La decisione rilevante, in questo contesto, non è introdurre una funzione, già condivisa, ma darle forma piena con una legge attuativa, strutturarla nei distretti delle tre aziende sanitarie e dimensionarla: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico del Friuli-Venezia Giulia emerge con nettezza: l'intervento non è da introdurre, ma da strutturare pienamente a partire da un impegno politico unanime e da una sperimentazione in avvio, che la regione deve portare a regime nei distretti delle tre aziende sanitarie, avvalendosi del coordinamento dell'ARCS, il modello, il sistema informativo e il monitoraggio.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire; nel Friuli-Venezia Giulia tale funzione è oggetto di un impegno politico unanime, la mozione consiliare del 2022, che ne prevede la collocazione negli ambulatori delle Case della Comunità.^[1033] La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria.^[1034] Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell'ordine di 239.000 persone con disagio comune.^[1035] La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per il Friuli-Venezia Giulia
Bisogno	~ 239.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Servizio di psicologia delle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo delle cure primarie nelle Case della Comunità e nei distretti, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impostazione della mozione consiliare del 2022, che prevede ambulatori di primo livello di assistenza psicologica ad accesso diretto del cittadino o su invio; la forma piena dell'inquadramento — convenzionale o dipendente — è ancora da definire in sede legislativa. Il Friuli-Venezia Giulia presenta qui una specificità: il servizio è sostenuto da un impegno politico unanime ma ancora in avvio sperimentale. La regione dispone di un'azienda regionale di coordinamento per la salute, l'ARCS, sicché strutturare il servizio nei distretti delle tre aziende sanitarie in modo omogeneo — in una regione di confine — è la sfida organizzativa principale, agevolata dal coordinamento dell'ARCS.^[1036] La rete territoriale delle Case della Comunità, in costruzione, è l'infrastruttura su cui il servizio andrà pienamente innestato. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.^[1037]

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, una valutazione iniziale con progetto clinico individuale, un ciclo di colloqui brevi con programma di sostegno personalizzato e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti; esso è in via di strutturazione nei distretti delle tre aziende sanitarie, e affronta i quadri più frequenti, dalla sintomatologia ansioso-depressiva ai problemi di adattamento e psicosomatici.^[1038] Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata.^[1039] Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici.^[1040] Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.^[1041]

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con la piattaforma informativa sanitaria regionale e con il fascicolo sanitario elettronico, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. Il coordinamento informativo è agevolato dalla presenza dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), che assicura funzioni tecnico-amministrative centralizzate, e deve garantire fra le tre aziende sanitarie l'uniformità della rilevazione man mano che il servizio vi viene strutturato.^[1042] La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale; poiché il servizio è ancora in avvio, il Friuli-Venezia Giulia ha l'opportunità di impostare il flusso fin dall'inizio in forma uniforme fra le tre aziende sanitarie, avvalendosi del coordinamento dell'ARCS e progettando correttamente la rilevazione prima della piena operatività anziché doverla ricostruire ex post.^[1043]

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale.^[1044] Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile.^[1045] L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica.^[1046] La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, nel Friuli-Venezia Giulia, lo strumento per garantire l'accesso nelle aree montane e interne della Carnia, del Friuli collinare e delle valli e la fruizione nella lingua del paziente, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza.^[1047] I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici.^[1048] La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle aree montane e interne (Carnia, valli) e fruizione nella lingua del paziente; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso gli atenei di Trieste e Udine e la SISSA; il livello post-universitario specialistico attraverso una formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, comprensiva della competenza per l'età anziana e la cronicità, prioritaria in una delle regioni più anziane d'Italia, per il disagio giovanile e per le competenze linguistiche in friulano, sloveno e tedesco; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione.^[1049] A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità, sostenuta dalla piattaforma informativa sanitaria regionale.^[1050] Il Friuli-Venezia Giulia presenta qui un elemento di metodo: l'Ordine professionale regionale ha già promosso una formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, base su cui innestare il percorso formativo dedicato. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Atenei di Trieste e Udine, SISSA
2. Post-universitario specialistico	Psicologia delle cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, competenza per l'età anziana e la cronicità e giovanile	Formazione promossa dall'Ordine regionale
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

Emilia-Romagna — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Emilia-Romagna

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d'eccellenza al servizio strutturato. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione Emilia-Romagna sulla riforma «Psicologo di Base». Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell'intero corpus: la premessa, l'indice generale di tutte le parti e di tutte le appendici, la mappa di integrazione delle cornici metodologiche e la sintesi del valore. L'Emilia-Romagna occupa, nel panorama nazionale, una posizione peculiare: è una regione di eccellenza, dotata di una rete territoriale matura — centoquarantuno Case della Comunità e una tradizione di Case della Salute avviata nel 2010 — nella quale la funzione psicologica nelle cure primarie è già diffusa per via amministrativa, attraverso esperienze strutturate dal 2015 nell'Azienda USL di Bologna e atti regionali quali le deliberazioni di Giunta del 2021 e del 2023, ma non è ancora istituzionalizzata da una legge regionale dedicata; la proposta di legge depositata nel 2024 non è stata approvata. La decisione rilevante non è dunque se introdurre il servizio, ma come strutturarlo e dimensionarlo, dando forma compiuta e stabile a una funzione già praticata.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell'intero corpus, che può essere percorso nell'ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.3	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, costo-efficacia distributiva, divari territoriali
Parte H	H.1-H.3	Profili etico, giuridico e organizzativo: etico, costituzionale, organizzativo e conformità
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: implementazione, dispiegamento, casi commerciale e gestionale, sostenibilità
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio, valutazione ed ex post: indicatori, protocollo, controfattuale, verifica ex post, cruscotto
Parte M	M.1-M.4	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: griglia OCSE-DAC, analisi multi-criterio, raccomandazioni, limiti
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati regionali e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — negativo per l'Emilia-Romagna, regione fortemente creditrice nella mobilità e dotata di un sistema già efficiente e di un livello essenziale di assistenza elevato — e il saldo complessivo, ampiamente positivo. La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 27	~ 40	~ 53
Risparmi diretti (SSR)	~ 16	~ 27	~ 40
Ricadute economico-sociali	~ 86	~ 160	~ 250
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -11	~ -13	~ -13
Saldo complessivo (caso economico)	+75	+147	+237
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,8:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante non è se prevedere il servizio — già praticato dal 2015 e diffuso per via amministrativa attraverso gli atti regionali del 2021 e del 2023 — ma se strutturarne e dimensionarlo, portandolo dalla diffusione amministrativa alla copertura del fabbisogno, dell'ordine di 960 incarichi nello scenario espansivo. Il limite principale è il radicamento dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione emiliano-romagnola, del 7,5%, e non estratte dai conti regionali certificati delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere-Universitarie; la loro sostituzione con dati certificati è la condizione per la presentazione agli organi di controllo.

Lo studio si fonda, sul piano comparativo, sui programmi internazionali più autorevoli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie — il programma inglese di terapie psicologiche, il modello olandese, l'iniziativa australiana e il Collaborative Care statunitense — dei quali mutua le evidenze di efficacia e di costo-efficacia, adattandole con cautela al contesto emiliano-romagnolo. La maturità della rete territoriale e della sanità digitale regionale rende inoltre l'Emilia-Romagna una candidata naturale a fungere da modello nazionale, anche per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel percorso assistenziale. Su questa base, e con la dichiarazione trasparente dei propri limiti, il corpus consegna al decisore un quadro completo e onesto su cui deliberare.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d'eccellenza al servizio strutturato

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell'HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per l'Emilia-Romagna, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia e al Veneto. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati all'Emilia-Romagna. Nell'architettura adottata

questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). È la parte che rende lo studio insieme rigoroso, riproducibile e confrontabile con quelli pugliese, lombardo e veneto e con quelli delle altre Regioni.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Servizio di Psicologia di Base nelle cure primarie dell'Emilia-Romagna, inteso come realizzazione strutturata e quantificata di una funzione psicologica territoriale che la regione ha già ampiamente avviato in via amministrativa e sperimentale — attraverso la Consultazione Psicologica Primaria, le linee di indirizzo regionali sulla psicologia nelle Case della Comunità e progetti aziendali consolidati in più Aziende USL — ma che non è ancora stata istituzionalizzata da una legge regionale dedicata né portata a un dimensionamento uniforme.^[1051] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sul portare il servizio a regime. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già diffusa e operante, oltre che oggetto di proposte di legge in corso d'esame — ma se strutturarla e dimensionarla in forma stabile e omogenea: gli atti di indirizzo e le esperienze esistono, ma un modello operativo unitario, un dimensionamento e una copertura sono ancora da definire, a fronte di un fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 970 psicologi. Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 890.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale dell'ordine di 66.000 persone, in un quadro segnato da tre componenti convergenti — il disagio connesso al lavoro nella popolazione attiva di un'economia dinamica e a forte tessuto manifatturiero, il bisogno dell'età anziana accentuato nelle aree appenniniche, e il bisogno connesso a una popolazione multiculturale in forte espansione — cui si aggiunge il disagio giovanile, in un sistema che, pur d'eccellenza, conosce liste di attesa prolungate. La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti emiliano-romagnoli con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è lo psicologo di base nelle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, portato a regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale coesistono una funzione già diffusa per via amministrativa e progetti aziendali consolidati, ma non un servizio strutturato e dimensionato in modo uniforme. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna, con le sue otto Aziende USL, le Aziende Ospedaliere-Universitarie, gli Istituti di ricovero e cura e la rete matura delle Case della Comunità. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per l'Emilia-Romagna
Popolazione	Residenti emiliano-romagnoli con disagio psichico comune (~890.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Psicologo di base nelle cure primarie, primo livello e filtro, portato a regime (~490/730/960 incarichi)
Confronto	Condizione attuale: funzione diffusa per via amministrativa e progetti aziendali, ma servizio non strutturato né dimensionato in modo uniforme
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna; otto Aziende USL, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS, rete delle Case della Comunità e 38 distretti

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell'HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell'OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l'intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e il servizio attuale come comparatore. Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Aziende USL e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale, ovvero servizio non strutturato né dimensionato a regime
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda USL e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. Tale prudenza assume, per l'Emilia-Romagna, un rilievo particolare: poiché la regione è a saldo di mobilità attivo tra i più elevati d'Italia — attrattore netto di pazienti da altre regioni — il canale del recupero della mobilità passiva non si applica; e poiché il sistema sanitario regionale è riconosciuto come benchmark nazionale per efficienza e appropriatezza, i margini di recupero diretto sono strutturalmente contenuti. Ne consegue che il saldo diretto risulta lievemente negativo e che il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, che lo studio stima con criteri conservativi. Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post. Decisivo anche per l'Emilia-Romagna è il disegno controfattuale: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Aziende USL, attivate in tempi diversi sotto il coordinamento della Regione, funge da esperimento naturale e consente di stimare l'effetto causale con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico. La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, le otto Aziende USL, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli Istituti di ricovero e cura, l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e le università regionali. A differenza del Veneto, l'Emilia-Romagna non dispone di un'azienda regionale unica di coordinamento: il veicolo per una progettazione unitaria e un'attuazione omogenea è costituito dalla Regione, attraverso la sua Direzione competente, e dall'Osservatorio regionale previsto dalle proposte di legge in esame, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. La maturità della rete territoriale — centoquarantuno Case della Comunità e trentotto distretti — costituisce l'infrastruttura su cui il servizio si innesta senza necessità di nuove strutture, ed è una caratteristica che distingue l'Emilia-Romagna e che la valutazione assume come risorsa per l'implementazione.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici; la solida infrastruttura di sanità digitale regionale colloca peraltro l'Emilia-Romagna nella posizione di apripista nazionale nella loro adozione. Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto dell'Emilia-Romagna.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d'eccellenza al servizio strutturato

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi e cornice normativa

Primo dominio dell'HTA · il problema di salute e il suo contesto

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto dell'Emilia-Romagna. La struttura è quella già adottata per la Puglia, per la Lombardia e per il Veneto, e mutano soltanto i dati, ancorati alla regione. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall'epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l'intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico dell'Emilia-Romagna: non un sistema in sofferenza da riequilibrare, ma un sistema d'eccellenza in cui una funzione già diffusa attende di essere strutturata e dimensionata.

B.1 Quadro demografico

L'Emilia-Romagna conta 4.451.938 residenti, pari a circa il 7,5% della popolazione nazionale, e presenta un tratto raro nel panorama italiano: la crescita della popolazione, in valore assoluto seconda soltanto alla Lombardia, sostenuta da un saldo migratorio positivo che compensa il saldo naturale negativo. L'aspettativa di vita, dell'ordine degli ottantatré-ottantaquattro anni, è tra le più elevate d'Italia e riflette la qualità dei determinanti socio-economici e dei servizi. La popolazione è caratterizzata da una componente straniera del 12,6%, nettamente superiore alla media nazionale, che agisce da motore della crescita e del ringiovanimento ma reca con sé bisogni specifici di salute mentale. Il territorio si articola in nove province, con la sola Bologna oltre il milione di abitanti e con un'accentuata variabilità interna fra la pianura e l'Appennino. La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per l'Emilia-Romagna
Popolazione (Censimento 2024)	4.451.938 (~7,5% del totale nazionale); in crescita
Aspettativa di vita	~ 83-84 anni, tra le più elevate d'Italia
Età media	~ 46-47 anni; ultra-ottantacinquenni in crescita
Componente straniera	12,6% dei residenti, nettamente sopra la media nazionale
Articolazione del territorio	Nove province; Bologna oltre 1.000.000 (22,9%), Modena 15,9%
Profilo per età	Composito: pianura urbana dinamica; Appennino anziano e in spopolamento
Articolazione sanitaria	Otto Aziende USL, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS Rizzoli

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico dell'Emilia-Romagna.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale in Emilia-Romagna, pur in un sistema efficiente, è elevato e in crescita. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali sulla popolazione regionale, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell'ordine di 890.000 persone, in larga parte non intercettate dall'offerta strutturata. A questa quota si somma un'utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale dell'ordine di 66.000 persone. Tre componenti orientano la domanda. La prima è il disagio giovanile, documentato per l'Emilia-Romagna da indagini regionali che ne misurano l'ampiezza già nella fascia adolescenziale. La seconda è il disagio connesso al lavoro nella popolazione attiva, particolarmente rilevante in un'economia a forte tessuto manifatturiero. La terza è il bisogno dell'età anziana, accentuato nelle aree appenniniche. A esse si aggiunge, quale tratto distintivo della regione, il bisogno connesso a una popolazione multiculturale in forte espansione. La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche dell'ordine di quarantamila-quarantatremila l'anno.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone un'offerta che, in Emilia-Romagna, presenta una fisionomia peculiare rispetto alle altre regioni esaminate: la funzione psicologica nelle cure primarie esiste già, ampiamente diffusa per via amministrativa e attraverso progetti aziendali consolidati, ma non è strutturata né dimensionata in modo uniforme. Il fabbisogno a regime è stimato nell'ordine di 970 psicologi, valore in linea con l'obiettivo indicato dall'Ordine professionale regionale di un presidio in ogni Casa della Comunità e in ognuno dei trentotto distretti. La copertura attuale è dunque parziale e disomogenea: non l'assenza di un servizio, come altrove, ma la sua incompiutezza e la sua disuguale distribuzione fra le aziende. La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per l'Emilia-Romagna
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 890.000 persone
Utenza stimata in carico ai Dipartimenti	~ 66.000
Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche	~ 40.000-43.000 l'anno
Offerta territoriale strutturata attuale	Funzione diffusa per via amministrativa e progetti aziendali; servizio non dimensionato in modo uniforme
Fabbisogno stimato a regime	~ 970 psicologi (930-1.020)
Copertura attuale del fabbisogno	Parziale e disomogenea; meno del 10% degli psicologi regionali opera nel servizio pubblico

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, in Emilia-Romagna, non assume la forma di un gradiente di deprivazione né quella di una frattura Nord-Sud, ma si articola su tre assi specifici. Il primo è la dualità territoriale fra la pianura urbana densamente popolata e produttiva e le aree appenniniche, più anziane e soggette a spopolamento, dove l'accesso ai servizi è strutturalmente più difficoltoso. Il secondo, peculiare della regione, è la dimensione multiculturale: la rilevante presenza straniera comporta barriere linguistiche e culturali all'accesso, che il servizio deve sapere affrontare con competenza dedicata. Il terzo è quello delle liste di attesa specialistiche, presenti anche in un sistema efficiente e ad alta domanda. Su tutti e tre gli assi il servizio di psicologia di base agisce in funzione di equità: avvicina l'offerta alle aree interne mediante la telepsicologia assistita, adotta un approccio culturalmente competente verso la popolazione migrante e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica e riduce i tempi di attesa.

B.5 I servizi e i flussi

Il Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna dispone di risorse complessive superiori ai dieci miliardi di euro ed è riconosciuto come benchmark nazionale, riferimento per la definizione dei costi standard e con elevati punteggi nei Livelli Essenziali di Assistenza; il disavanzo, coperto integralmente dalla Regione, è stato ridotto progressivamente verso il pareggio, e la regione non è soggetta a piano di rientro. Diversamente dalle regioni meridionali, e analogamente alla Lombardia e al Veneto, l'Emilia-Romagna è attrattore netto di pazienti, con un saldo di mobilità attivo dell'ordine di 525 milioni di euro: ne consegue che il canale del recupero della mobilità passiva, centrale altrove, qui non si applica. L'architettura dei servizi poggia su otto Aziende USL, sulle Aziende Ospedaliero-Universitarie e sugli Istituti di ricovero e cura, e su una rete territoriale matura — centoquarantuno Case della Comunità e ventiquattro Ospedali di Comunità — che costituisce l'infrastruttura pronta ad accogliere il servizio. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per l'Emilia-Romagna
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	> 10 miliardi di euro; benchmark nazionale; verso il pareggio; nessun piano di rientro
Mobilità sanitaria attiva	saldo +525 milioni di euro (regione creditrice; canale non applicabile)
Accessi al pronto soccorso	~ 1.400.000 l'anno
Architettura dei servizi	Otto AUSL, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS; 141 Case della Comunità, 24 Ospedali di Comunità
Margine di azione principale	Liste di attesa, completamento della funzione psicologica, accesso delle aree appenniniche e della popolazione straniera

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice normativa che, in Emilia-Romagna, è ricca di atti amministrativi e programmatici ma priva, allo stato, di una legge regionale dedicata. Il percorso delle Case della Salute, avviato nel 2010, ha predisposto l'infrastruttura territoriale; le linee di indirizzo regionali del 2021 e del 2023 hanno riconosciuto la Casa della Comunità come setting ideale della funzione psicologica e ne hanno avviato l'implementazione; il progetto di legge del 2024 e la proposta di legge di iniziativa popolare, in corso d'esame, ne propongono l'istituzionalizzazione, prevedendo almeno uno psicologo ogni cinque medici di medicina generale per distretto, elenchi provinciali e un Osservatorio regionale. Sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera, il Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — che ha confermato la competenza regionale in materia — compongono il quadro di riferimento. La decisione rilevante, in questo contesto, non è introdurre la funzione, ma strutturarla e dimensionarla in forma stabile e omogenea: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d'eccellenza al servizio strutturato

Parte C

L'intervento e il suo modello

Definizione, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali e formazione

Secondo dominio dell'HTA · la descrizione della tecnologia

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti

digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico dell'Emilia-Romagna emerge con nettezza: l'intervento non si innesta su un vuoto, ma su una rete territoriale matura e su una funzione già sperimentata, di cui si tratta di dare forma stabile, uniforme e dimensionata.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire. La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria, ossia dell'intercettare prima che il disturbo si cronicizzi. Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell'ordine di 890.000 persone con disagio comune. La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per l'Emilia-Romagna
Bisogno	~ 890.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Psicologo nelle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, particolarmente nella popolazione attiva, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo di base nelle Case della Comunità e nei Nuclei delle Cure Primarie, in collaborazione con i medici di medicina generale e secondo protocolli condivisi. Su questo punto l'Emilia-Romagna presenta una specificità istituzionale rispetto al Veneto: non disponendo di un'azienda regionale unica, il coordinamento, l'omogeneità attuativa fra le otto Aziende USL e le economie di scala sono affidati alla Regione, attraverso la sua Direzione competente, e all'Osservatorio regionale previsto dalle proposte di legge in esame. La rete territoriale matura — le centoquarantuno Case della Comunità e i trentotto distretti — è l'infrastruttura su cui il servizio si innesta senza necessità di nuove strutture, un vantaggio che distingue l'Emilia-Romagna e che il modello assume come risorsa. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su invio del medico di medicina generale — nella forma già sperimentata in regione della Consultazione Psicologica Primaria — o l'accesso diretto, una valutazione iniziale, un ciclo di colloqui brevi e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti. Gli

esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata. Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con il fascicolo sanitario elettronico regionale, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. In coerenza con l'assetto di governo descritto, il coordinamento informativo è in capo alla Regione e all'Osservatorio regionale, che ne assicurano l'uniformità fra le otto Aziende USL. La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale, e va perciò prevista fin dall'avvio del servizio; è un punto su cui la maturità dei sistemi informativi regionali offre all'Emilia-Romagna una posizione di vantaggio.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale. Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile. L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica. La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, in Emilia-Romagna, lo strumento per garantire l'accesso nelle aree appenniniche, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza. I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici. La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle aree appenniniche; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso le quattro università della regione — Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e Ferrara; il livello post-universitario specialistico attraverso un corso regionale con attestato dedicato alla psicologia di base e alle cure primarie, comprensivo della competenza culturale necessaria per una popolazione fortemente multiculturale; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione. A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità; è su questo terreno che la solida infrastruttura di sanità digitale regionale candida l'Emilia-Romagna a contesto esemplare e apripista nazionale. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma, Ferrara
2. Post-universitario specialistico	Psicologia di base e cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, competenza culturale	Corso regionale con attestato
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d’eccellenza al servizio strutturato

Parte D

L’*****efficacia e l’*****evidenza

Revisione sistematica, qualità dell’evidenza, benchmark internazionali e trasferibilità

Terzo e quarto dominio dell’HTA · l’efficacia clinica e la sicurezza

Parte D — L’efficacia e l’evidenza

Descritto l’intervento nella Parte C, questa quarta parte ne esamina l’efficacia e l’evidenza, secondo il terzo e il quarto dominio della valutazione. La base di prove è in larga misura indipendente dalla regione, poiché attinge alla letteratura internazionale e ai programmi consolidati; ciò che muta è il giudizio di trasferibilità, calibrato sul contesto emiliano-romagnolo. La parte presenta la revisione sistematica delle prove (capitolo D.1); ne valuta la qualità con il sistema GRADE (D.2); esamina i benchmark internazionali e italiani (D.3); e discute la trasferibilità al contesto regionale (D.4), dove acquista rilievo il patrimonio di evidenza locale costituito dai progetti aziendali già attivi in regione.

D.1 La revisione sistematica

La sintesi delle prove è condotta secondo i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale, con preferenza per le fonti più recenti. Il quadro che ne emerge è solido. Lo studio fondativo del modello collaborativo ha documentato un tasso di risposta di circa il 50% dei pazienti trattati, contro il 19% della cura usuale. Una meta-analisi su cinquantasette studi controllati ha stimato un miglioramento medio dei sintomi depressivi di 0,28 deviazioni standard. Una revisione di quarantadue implementazioni ha rilevato riduzioni dell’ordine del 47% della depressione, del 43% dell’ansia, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. Il programma inglese, su scala di oltre 1,3 milioni di persone l’anno, conferma questi valori con dati reali. Una meta-analisi sulle cure integrate, infine, stima un effetto modesto sul singolo ma clinicamente rilevante sulla popolazione. La tabella seguente sintetizza i principali risultati.

Fonte	Risultato principale
Studio fondativo (JAMA, 2002)	~ 50% dei pazienti con riduzione ≥ 50% dei sintomi a 12 mesi, contro 19% nella cura usuale
Meta-analisi su 57 studi (2012)	Miglioramento medio dei sintomi depressivi di 0,28 deviazioni standard
Revisione su 42 implementazioni (2024)	–47% depressione e –43% ansia a 6 mesi; –34% accessi al PS; –41% ricoveri
Programma inglese, dati reali (2023-2024)	Recupero 50,2%; miglioramento affidabile 67,8%; completezza dei dati > 98%
Meta-analisi sulle cure integrate	Coefficiente standardizzato –0,11 sui sintomi depressivi (clinicamente rilevante su popolazione)

Tabella D.1. Principali risultati della letteratura sull'*******efficacia dell'*******integrazione psicologica nelle cure primarie.

D.2 La qualità dell'evidenza

La qualità dell'evidenza, valutata con il sistema GRADE, è da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni, mentre è più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. Una cautela merita di essere dichiarata con franchezza, perché orienta l'intera impostazione economica dello studio: nello stesso studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l'intervallo di confidenza comprende lo zero. Il valore economico del modello, di conseguenza, poggia in misura preponderante sui ritorni sociali e non sui risparmi sanitari diretti. È una cautela coerente con il profilo del caso economico emiliano-romagnolo, che la Parte E costruisce esattamente su questa base.

D.3 I benchmark internazionali

L'evidenza sperimentale è corroborata dall'esperienza dei grandi programmi internazionali, che offrono modelli organizzativi maturi e dati su larga scala. Il programma inglese costituisce il riferimento principale per l'organizzazione del servizio. Il modello olandese mostra un'integrazione capillare nello studio del medico di base. L'iniziativa australiana documenta l'ampliamento della popolazione in trattamento. Il modello statunitense è validato da una mole imponente di studi controllati. Le esperienze italiane, infine, pur derivando da campioni limitati, anticipano l'integrazione nelle cure primarie. La tabella seguente li riepiloga.

Programma	Assetto	Esiti clinici e organizzativi
Programma inglese (NHS Talking Therapies)	Integrato; intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio > 98%; > 1,3 mln/anno
Modello olandese (POH-GGZ)	Integrato nelle cure primarie	Adozione ~3/4 dei medici; ruolo complementare
Iniziativa australiana (Better Access)	Invio esterno	Trattamento dal 35% al 46%; elevata soddisfazione
Collaborative Care (Stati Uniti)	Équipe integrata	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione; -41% ricoveri
Esperienze italiane (Solano, Lazio)	Sperimentazione locale	Anticipazione del modello nelle cure primarie

Tabella D.2. I benchmark internazionali e italiani sul piano clinico e organizzativo (il confronto economico è nella Parte E).

D.4 La trasferibilità al contesto regionale

La trasposizione di questi risultati al contesto regionale richiede cautela metodologica: i programmi internazionali provengono da sistemi diversi per organizzazione, finanziamento e cultura, e le loro stime — di efficacia e, ancor più, economiche — non vanno trasferite meccanicamente, ma validate localmente. Per l'Emilia-Romagna, tuttavia, la trasferibilità è facilitata da una circostanza non comune: la regione dispone già di una base di evidenza locale di particolare valore, costituita dai progetti aziendali consolidati di psicologia nelle cure primarie, fra cui l'esperienza dell'AUSL di Bologna avviata nel 2015, che ha mostrato la capacità del servizio di intercettare un'utenza in larga parte mai entrata in contatto con i servizi di salute mentale. A ciò si

aggiungono la solidità organizzativa del sistema, riconosciuto come benchmark nazionale, e la maturità della rete delle Case della Comunità, che insieme costituiscono un terreno favorevole all’adozione del modello e alla sua valutazione rigorosa. Una precisazione conclusiva si impone sul piano della correttezza: i rapporti beneficio-costo spesso citati nel dibattito pubblico sono semplificazioni divulgative; le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno in intervalli più prudenti, ed è a questi che lo studio si attiene. Stabilita l’efficacia e graduata l’evidenza, la parte che segue ne traduce i risultati nella valutazione economica.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d’eccellenza al servizio strutturato

Parte E

La valutazione economica

Costi, esiti, costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale e casi economico e finanziario

Quinto dominio dell’HTA · il valore economico

Parte E — La valutazione economica

Stabilita l’efficacia nella Parte D, questa quinta parte ne traduce i risultati in termini economici, secondo il quinto dominio della valutazione e nel rigore di reporting dello standard CHEERS. È la parte centrale per il decisore di finanza pubblica, e ne riassume l’esito già in apertura: il caso finanziario, riferito al solo bilancio sanitario, presenta un saldo lievemente negativo, mentre il caso economico, riferito alla collettività, è ampiamente positivo. La parte identifica e misura i costi (capitolo E.1) e gli esiti (E.2); ne deriva il costo-efficacia e il costo-utilità (E.3); analizza l’impatto sul bilancio (E.4); stima il ritorno sociale (E.5); e ricompone il caso economico e il caso finanziario (E.6). I valori sono espressi in tre scenari di copertura, e l’intera analisi tiene rigorosamente distinto ciò che lo Stato risparmia da ciò che la collettività guadagna.

E.1 L’identificazione e la misura dei costi

Il costo del servizio comprende le remunerazioni dei professionisti, i costi organizzativi e di coordinamento e la quota destinata alla formazione congiunta, ed è stimato per scenario di copertura ed espresso a regime. A regime, esso è dell’ordine di 27 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 40 nello scenario base e 53 nello scenario espansivo. La stima muove da un valore unitario per incarico dell’ordine di 55.000 euro annui, regionalizzato in proporzione alla popolazione e al numero di professionisti, con economie di scala rese possibili dal coordinamento regionale e dalla maturità della rete. La tabella seguente espone il costo per scenario; la condizione attuale, in cui la funzione è diffusa ma non strutturata a regime, comporta una spesa dedicata prossima allo zero.

Scenario	Psicologi	Costo annuo (mln €)
Attuale (funzione diffusa, non strutturata)	Servizio non dimensionato	~ 0
Conservativo	~ 490	~ 27
Base	~ 730	~ 40
Espansivo	~ 960	~ 53

Tabella E.1. Il costo del servizio per scenario di copertura. La funzione è oggi diffusa per via amministrativa ma non strutturata a regime.

E.2 L'identificazione e la misura degli esiti

Gli esiti di salute sono espressi in anni di vita ponderati per la qualità e in esiti clinici validati; i tassi di recupero e di miglioramento sono desunti dai benchmark consolidati e applicati in via prudenziale. Le misure impiegate, nei soli punteggi complessivi, sono il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia, con un tasso di recupero di riferimento dell'ordine del 50%, coerente con i dati reali del programma inglese.

E.3 Il costo-efficacia e il costo-utilità

Il costo per anno di vita ponderato per la qualità si colloca al di sotto della soglia comunemente adottata; l'analisi per paziente, sviluppata in dettaglio nella Parte F, indica anzi condizioni di dominanza dell'intervento rispetto all'opzione di non intervento, ossia un esito al tempo stesso migliore e meno costoso sul ciclo di vita del disturbo. La soglia di riferimento adottata è dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, in linea con la prassi internazionale.

E.4 L'impatto sul bilancio

L'analisi di impatto sul bilancio misura i risparmi diretti per il Servizio sanitario regionale, articolati nei canali del pronto soccorso, della farmaceutica e dei ricoveri e prestazioni specialistiche evitabili; per l'Emilia-Romagna il canale della mobilità recuperata è nullo, poiché la regione è a saldo di mobilità attivo. I risparmi diretti complessivi sono stimati nell'ordine di 16, 27 e 40 milioni di euro annui nei tre scenari, collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa dell'intervallo in ragione dell'elevata efficienza del sistema regionale. Il saldo diretto, differenza tra risparmi diretti e costo del servizio, è dell'ordine di -11, -13 e -13 milioni di euro annui: lievemente negativo, coerentemente con la natura di regione creditrice e con l'elevata appropriatezza di partenza. Questo saldo negativo è dichiarato senza attenuazioni e non rappresenta una debolezza dell'analisi, ma il suo profilo onesto: a differenza della Puglia, dove il recupero della mobilità passiva concorre al pareggio diretto, in Emilia-Romagna il valore dell'intervento risiede in misura preponderante nelle ricadute sociali. La tabella seguente dettaglia i canali e il saldo.

Canale (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Pronto soccorso	3	5	6
Farmaceutica	3	5	8
Ricoveri e specialistica	10	17	26
Mobilità recuperata	0	0	0
Risparmi diretti (totale)	~ 16	~ 27	~ 40
Costo del servizio	~ 27	~ 40	~ 53
Saldo diretto (solo SSR)	~ -11	~ -13	~ -13

Tabella E.2. I risparmi diretti per canale e il saldo diretto sul bilancio sanitario, per scenario. Il saldo diretto è lievemente negativo.

E.5 Il ritorno sociale

Il valore dell'intervento, in Emilia-Romagna, si manifesta soprattutto al di fuori del bilancio sanitario. Le ricadute economico-sociali comprendono la maggiore produttività recuperata, la riduzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, le efficienze nel sistema dei servizi di salute mentale e il sollievo alle figure di cura familiari; in un'economia a forte tessuto manifatturiero e a elevata occupazione, la produttività recuperata è la voce di maggior peso. Stimate secondo i metodi del ritorno sociale sull'investimento e con criteri conservativi, queste ricadute sono dell'ordine di 86 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 160 nello scenario base e 250 nello scenario espansivo.

E.6 Il caso economico e il caso finanziario

La ricomposizione delle grandezze restituisce il quadro complessivo. Il ritorno complessivo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali, è dell'ordine di 102, 187 e 290 milioni di euro annui nei tre scenari; al netto del costo del servizio, il saldo complessivo è dell'ordine di +75, +147 e +237 milioni di euro annui. Il rapporto beneficio-costi complessivo è conseguentemente dell'ordine di 3,8:1 nello scenario conservativo, 4,7:1 nel base e 5,5:1 nell'espansivo, in linea con il valore validato sulle altre regioni. La lettura corretta del risultato passa per la distinzione, propria del Five Case Model, tra il caso finanziario — riferito al solo bilancio sanitario e lievemente negativo — e il caso economico — riferito alla collettività e ampiamente positivo. Sul piano della sostenibilità, il costo del servizio si colloca nell'ordine dello 0,3-0,5% di un Fondo Sanitario Regionale superiore ai dieci miliardi di euro, importo pienamente sostenibile per un sistema solido e prossimo al pareggio. Resta la lacuna prioritaria, già dichiarata: le grandezze economiche sono in parte ricostruite per quota di popolazione e non estratte dai conti regionali certificati, la cui verifica presso le aziende è condizione per la presentazione alle autorità di finanza pubblica. La tabella seguente sintetizza il caso economico e il caso finanziario.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Risparmi diretti (SSR)	~ 16	~ 27	~ 40
Ricadute economico-sociali	~ 86	~ 160	~ 250
Ritorno complessivo	~ 102	~ 187	~ 290
Costo del servizio	~ 27	~ 40	~ 53
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -11	~ -13	~ -13
Saldo complessivo (caso economico)	+75	+147	+237
Rapporto beneficio-costi complessivo	~3,8:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella E.3. Sintesi economica per scenario: il caso finanziario (saldo diretto negativo) e il caso economico (saldo complessivo positivo).

Parte F

Modellazione decisionale e incertezza

Struttura del modello, parametri, sensibilità deterministica e probabilistica, valore dell’informazione

Quinto dominio dell’HTA · la modellazione e l’incertezza

Parte F — Modellazione decisionale e incertezza

Questa parte completa il quinto dominio sviluppando la modellazione decisionale che sorregge le stime economiche della Parte E e la gestione esplicita dell’incertezza. Il modello e i suoi risultati per paziente sono di natura clinica ed economica generale e sono pertanto indipendenti dalla regione: ciò che muta sono i soli riferimenti al contesto e alle fonti di calibrazione regionale. La parte descrive la struttura del modello (capitolo F.1); ne specifica i parametri e la calibrazione (F.2); ne saggia la robustezza con la sensibilità deterministica (F.3) e con quella probabilistica (F.4); e ne trae le priorità di acquisizione dei dati con il valore dell’informazione (F.5). Il risultato per paziente — una dominanza dell’intervento — è il fondamento microeconomico su cui poggiano le stime aggregate, e ne spiega la coerenza con il saldo diretto regionale.

F.1 La struttura del modello

La modellazione segue le buone pratiche di ricerca riconosciute ed è riportata secondo lo standard CHEERS.^{[1052][1053][1054]} Lo strumento adottato è un modello di Markov a coorte, che rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi — sintomatico, recupero, cronico, morte — scanditi da cicli con correzione di metà ciclo.^[1055] Nel caso base, riferito a un singolo paziente su orizzonte quinquennale e a valori scontati, il braccio dell’intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un’utilità di 3,627 anni di vita ponderati, contro 3.799 euro e 3,392 dell’assistenza usuale: l’intervento è al tempo stesso meno costoso e più efficace, configurando una dominanza.^[1056] La dominanza non è un artificio, ma la conseguenza della struttura del modello: l’intervento accresce il tempo nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce il tempo nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte.^[1057] La tabella seguente riporta i risultati del caso base.

Caso base, per paziente	Intervento	Cura usuale	Differenza
Costo sanitario (5 anni, scontato)	~ 2.495 €	~ 3.799 €	– 1.304 €
Utilità (anni di vita ponderati)	3,627	3,392	+ 0,236
Esito	—	—	Dominanza (più efficace, meno costoso)

Tabella F.1. Risultati del caso base del modello di Markov, per paziente, su orizzonte quinquennale scontato.

F.2 I parametri e la calibrazione

I parametri di costo del modello, per ciclo, sono dell’ordine di 40 euro per lo stato di recupero, 700 euro per lo stato cronico e 300 euro per l’intervento psicologico una tantum; è questa struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l’intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso.^[1058] Alle grandezze

sono assegnate distribuzioni di probabilità per l’analisi probabilistica: Beta per le probabilità di transizione e per le utilità, vincolate tra zero e uno, e Gamma per i costi, vincolati ai valori positivi; i valori centrali sono tratti dall’evidenza internazionale e, per i parametri regionali, sono da calibrare sui valori emiliano-romagnoli certificati non appena disponibili.^[1059] La tabella seguente riepiloga i principali parametri e le distribuzioni assegnate.

Parametro	Valore	Distribuzione
Costo per ciclo — stato di recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — stato cronico	700 €	Gamma
Costo dell’intervento psicologico (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione tra gli stati	da fonti, per braccio	Beta
Utilità associate agli stati	da fonti	Beta

Tabella F.2. Principali parametri del modello e distribuzioni assegnate per l’analisi probabilistica.

F.3 La sensibilità deterministica

La robustezza del risultato è saggiata, in prima istanza, con un’analisi di sensibilità a una via, nella quale ciascun parametro è fatto variare del 25% in più e in meno, misurandone l’effetto sul beneficio monetario netto; il diagramma a tornado ordina i parametri per influenza, individuando nell’efficacia clinica, nei tassi di ricaduta e di cronicizzazione e nel costo dello stato cronico i fattori più determinanti.^[1060] Oltre all’incertezza dei parametri, l’incertezza sulla struttura e sulle assunzioni del modello è trattata mediante analisi di scenario, con validazione della coerenza interna ed esterna secondo lo standard di reporting adottato.^[1061]

F.4 La sensibilità probabilistica e la curva di accettabilità

L’analisi di sensibilità probabilistica esegue il modello diecimila volte, estraendo a ogni iterazione i parametri dalle rispettive distribuzioni, così da propagare l’incertezza dei parametri sull’incertezza del risultato.^[1062] Adottando la soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità,^[1063] la curva di accettabilità indica una probabilità dell’88,9% che l’intervento sia costo-efficace e dell’84,6% che sia addirittura dominante, con un beneficio monetario netto medio di circa 7.815 euro per paziente e un intervallo di credibilità al 95% compreso fra circa -5.736 e circa +21.501 euro.^[1064] È qui necessario chiarire la coerenza, solo apparentemente paradossale, tra questo risultato e il saldo diretto regionale: la probabilità di costo-efficacia è una misura di efficienza per paziente, che valorizza il guadagno di salute e l’intera traiettoria di costo, mentre il saldo diretto aggregato della Parte E, negativo per l’Emilia-Romagna, incorpora le correzioni per peso morto e per l’effettiva monetizzabilità nel bilancio dei costi evitati e sconta l’assenza del canale della mobilità. L’efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali.^[1065] La tabella seguente sintetizza i risultati.

Misura dell'analisi probabilistica	Risultato
Iterazioni della simulazione Monte Carlo	10.000
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 €/QALY)	88,9%
Probabilità di dominanza	84,6%
Beneficio monetario netto medio	~ 7.815 € per paziente
Intervallo di credibilità al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 €

Tabella F.3. Risultati dell'analisi di sensibilità probabilistica (per paziente, soglia 30.000 €/QALY).

F.5 Il valore dell'informazione

L'analisi del valore dell'informazione chiude il dominio traducendo l'incertezza residua in priorità di ricerca: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali grandezze sia prioritario misurare con precisione.^[1066] Per l'Emilia-Romagna, i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso, essendo il canale della mobilità non applicabile — sono quelli su cui il valore dell'informazione è più elevato, e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati alle aziende.^[1067] La via maestra per ridurre l'incertezza, infine, non è soltanto analitica ma empirica: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Aziende USL, oggetto della Parte L, consente di sostituire progressivamente le stime con misure osservate sui dati regionali.^[1068] Completato così il nucleo della valutazione — efficacia, economia, modellazione — le parti successive ne affrontano le dimensioni distributive, etiche, organizzative e valutative, a partire dall'equità.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d'eccellenza al servizio strutturato

Parte G

Equità e impatto distributivo

Analisi di equità, costo-efficacia distributiva, divari territoriali e impoverimento

Ottavo dominio dell'HTA · il profilo del paziente e sociale

Parte G — Equità e impatto distributivo

Misurato il valore economico nelle Parti E ed F, questa settima parte ne esamina la distribuzione, secondo l'ottavo dominio della valutazione. La domanda non è soltanto se l'intervento generi valore, ma a chi quel valore arrivi: un intervento può essere efficiente e tuttavia accrescere le disuguaglianze, oppure, come in questo caso, migliorare l'esito medio e ridurle insieme. La parte definisce le dimensioni dell'equità e le variabili seguite (capitolo G.1); applica gli strumenti della costo-efficacia distributiva (G.2); e analizza i divari territoriali e l'impoverimento (G.3). Per l'Emilia-Romagna, l'equità si gioca su due assi peculiari — la dualità fra pianura e Appennino e la dimensione multiculturale — piuttosto che sul gradiente di deprivazione.

G.1 L'analisi di equità

L'equità è trattata come dimensione costitutiva della valutazione, e non come considerazione accessoria.^[1069]
^[1070]^[1071]^[1072]^[1073]^[1074]^[1075]^[1076]^[1077]^[1078]^[1079]^[1080]^[1081]^[1082] La salute mentale presenta ovunque un gradiente sociale, ma in Emilia-Romagna, dove il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato, il gradiente socio-economico non è il tratto distintivo: prevalgono due dimensioni diverse, la dualità fra la pianura produttiva e le aree appenniniche e la dimensione multiculturale, propria di una regione con una quota di residenti stranieri del 12,6%.^[1083] La gratuità, la prossimità e l'assenza di stigma del servizio di primo livello abbattano le barriere che gravano sulle popolazioni svantaggiate, e in Emilia-Romagna rilevano in particolare l'abbattimento della barriera geografica nell'Appennino e di quella linguistico-culturale per la popolazione straniera.^[1084] La tabella seguente espone le dimensioni dell'equità e le variabili che lo studio segue.^[1085]

Dimensione di equità	Variabili seguite dallo studio
Accesso	Tempi di attesa; accessibilità geografica nelle aree appenniniche; contrasto alle liste di attesa
Protezione finanziaria	Riduzione della spesa privata diretta; dell'impoverimento connesso alle cure; delle spese catastrofiche
Gruppi vulnerabili	Equità di genere; popolazione straniera (12,6%) e gruppi fragili; persone con disabilità; barriere culturali e linguistiche; gratuità
Territorio	Riduzione del divario pianura-Appennino; copertura del bisogno non soddisfatto

Tabella G.1. Le dimensioni dell'equità e le variabili seguite dallo studio.

G.2 La costo-efficacia distributiva

La dimensione distributiva è misurata con gli strumenti della costo-efficacia distributiva, che estendono la valutazione economica all'equità stimando come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l'effetto sulle disuguaglianze.^[1086] La direzione del risultato è favorevole: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove l'accesso è oggi più difficile — le aree appenniniche, la popolazione straniera e i gruppi gravati dalle liste di attesa — i benefici si concentrano sui più svantaggiati, riducendo il gradiente territoriale e migliorando al tempo stesso l'esito medio.^[1087] L'attribuzione di pesi maggiori ai benefici dei più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, in via conservativa, il rapporto non ponderato già esposto, tanto più prudente in una regione non prevalentemente deprivata.^[1088] Il meccanismo operativo dell'equità è un algoritmo allocativo che distribuisce gli incarichi non secondo la sola popolazione, ma ponderando ciascun distretto per l'invecchiamento, la deprivazione, la cronicità e la presenza straniera.^[1089] A tal fine si impiega un indice di deprivazione multipla che sintetizza reddito, occupazione, istruzione, salute, condizione abitativa e ambiente.^[1090] La tabella seguente riepiloga gli strumenti.

Strumento della costo-efficacia distributiva	Che cosa misura
Anni di vita ponderati per l'equità	Guadagni di salute con pesi per lo svantaggio
Indice di concentrazione	Relazione tra esito di salute e posizione socio-economica
Indici di disuguaglianza (assoluta e relativa)	Gradiente dell'esito lungo lo stato socio-economico
Valutazione d'*****impatto sull'*****equità	Distribuzione degli effetti per gruppi vulnerabili e per area
Indice di deprivazione multipla	Reddito, occupazione, istruzione, salute, abitare, ambiente

Tabella G.2. Gli strumenti della costo-efficacia distributiva e dell'analisi di equità.

G.3 I divari territoriali e l'impoverimento

Il divario territoriale rilevante, in Emilia-Romagna, non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra la pianura densa e produttiva, ben servita, e le aree appenniniche, a popolazione anziana e dispersa e soggette a spopolamento, dove la sola presenza fisica di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio, integrato dalla telepsicologia.^[1091] Essendo la regione creditrice nella mobilità, il canale del suo recupero non si applica, sicché le principali leve distributive diventano la riduzione delle liste di attesa, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato, il completamento uniforme della funzione fra le otto Aziende USL e la cura culturalmente competente per la popolazione straniera.^[1092] A queste si aggiunge la protezione finanziaria: il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata per la psicoterapia e l'impoverimento connesso alle cure, con beneficio maggiore per i redditi bassi.^[1093] La forma più elementare di equità, infine, è la copertura del bisogno non soddisfatto, dell'ordine di 890.000 persone in larga parte non intercettate, ossia il raggiungere proprio coloro che meno accedrebbero spontaneamente ai servizi.^[1094] Tutti questi profili sono tradotti in indicatori e affidati al sistema di monitoraggio della Parte L, che ne accerta nel tempo il conseguimento.^[1095] Definita la dimensione distributiva, la parte che segue affronta i profili etico, giuridico e organizzativo.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d'eccellenza al servizio strutturato

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Profilo etico, profili giuridici e costituzionali, profilo organizzativo e conformità

Domini sei, sette e nove dell'HTA · etica, organizzazione e diritto

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte completa la valutazione affrontando i tre domini che restano oltre quelli già trattati: il profilo etico, il profilo giuridico e costituzionale e il profilo organizzativo e di conformità. Sono i piani che ne sagghiano la legittimità e l'ammissibilità — non basta che un intervento sia efficace ed efficiente, occorre che sia eticamente fondato, giuridicamente legittimo e organizzativamente conforme. La parte esamina il profilo etico (capitolo H.1); i profili giuridici e costituzionali, con specifico riguardo alla competenza regionale (H.2); e il profilo

organizzativo e la conformità, segnatamente degli strumenti di intelligenza artificiale (H.3). Per l'Emilia-Romagna, il punto giuridico saliente è che la decisione opera entro la competenza organizzativa regionale, su una funzione già diffusa per via amministrativa.

H.1 Il profilo etico

Il profilo etico dell'intervento è solido.^{[1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111]} Le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, già trattata, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato, con la persona sempre soggetto e mai oggetto della presa in carico.^[1112] Il consenso è modulare e reso anche in forma digitale, e nella salute mentale, dove i dati sono ultrasensibili, la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi vi acceda.^[1113] Sul piano della condotta della ricerca, gli esiti sono resi pubblici a prescindere dal loro segno, a garanzia contro la selezione dei risultati favorevoli, e l'impianto è sottoposto al comitato etico competente.^[1114] Una cautela specifica presidia i minori e le persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e dell'emergenza in raccordo con il medico curante.^[1115]

H.2 I profili giuridici e costituzionali

Sul piano giuridico, l'intervento si fonda anzitutto sull'articolo 32 della Costituzione e sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che configurano la salute come diritto fondamentale e il servizio come universale, eguale ed equo.^[1116] Il riparto di competenze è il punto dirimente: la tutela della salute è materia concorrente, nella quale alle Regioni spetta l'organizzazione del servizio, e gli atti regionali emiliano-romagnoli operano legittimamente entro tale competenza.^[1117] La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni resta invece competenza esclusiva dello Stato, ed è la leva di un'eventuale uniformazione nazionale.^[1118] Di rilievo diretto è la sentenza della Corte costituzionale del 2021, che ha riconosciuto legittimo il modello regionale di psicologia di base in quanto organizzazione che si avvale di professionisti già esistenti: un precedente che conforta la scelta dell'Emilia-Romagna di strutturare una funzione già diffusa.^[1119] La base regionale di tale scelta è ricca — dalle Case della Salute alle deliberazioni di Giunta sulla psicologia di comunità, fino alle proposte di legge in esame — e si avvale, in assenza di un'azienda regionale unica, del coordinamento della Regione e dell'Osservatorio regionale.^[1120] Una sentenza costituzionale del 2026 ha infine ribadito che le Regioni in piano di rientro non possono distogliere i fondi sanitari dai livelli essenziali; vincolo cui l'Emilia-Romagna, prossima al pareggio e non in rientro, non è soggetta.^[1121] La tabella seguente riepiloga i riferimenti.

Riferimento giuridico	Contenuto rilevante
Articolo 32 Cost. e legge n. 833/1978	Salute come diritto; Servizio sanitario universale, eguale ed equo
Articolo 117, terzo comma, Cost.	Tutela della salute: competenza concorrente (principi allo Stato, organizzazione alle Regioni)
Articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.	Livelli essenziali delle prestazioni: competenza esclusiva statale
DGR n. 1141/2021 e n. 2185/2023	Base regionale: psicologia clinica e di comunità; implementazione nelle Case della Comunità; coordinamento regionale
Corte costituzionale, sentenza n. 241/2021	Modello regionale di psicologia di base riconosciuto legittimo (precedente)
Corte costituzionale, sentenza n. 6/2026	Vincolo dei fondi ai livelli essenziali per le regioni in rientro (non applicabile all'Emilia-Romagna)

Tabella H.1. I riferimenti giuridici e costituzionali essenziali dell'intervento.

H.3 Il profilo organizzativo e la conformità

Sul piano organizzativo, il servizio opera nel rispetto delle norme deontologiche della professione, sotto la vigilanza dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, che concorre alla governance e alla formazione. ^[1122] L'impiego dell'intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali: il medico resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell'intervento psicologico, e l'intelligenza artificiale è assimilata a un dispositivo di supporto e non a una figura che compie atti, sicché non si introduce una nuova professione, ma uno strumento che assiste quelle esistenti. ^[1123] La conformità degli strumenti è governata dal quadro europeo — il regolamento sull'intelligenza artificiale, quello sui dispositivi medici e quello sulla protezione dei dati — cui si aggiungono la supervisione umana costante, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias e la trasparenza. ^[1124] Una particolare attenzione è dedicata all'equità digitale, perché gli strumenti non generino nuove disuguaglianze: sono previsti canali tradizionali per le persone anziane delle aree appenniniche e il supporto multilingue per la popolazione straniera, sempre con l'alternativa in presenza garantita. ^[1125] La protezione dei dati, infine, è assicurata da misure robuste di sicurezza, dal consenso modulare e dalla collaborazione con l'Autorità garante. ^[1126] La tabella seguente riepiloga il quadro della conformità e della governance. Definiti i profili etico, giuridico e organizzativo, la parte che segue affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

Ambito	Riferimento	Garanzia
Deontologia	Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna	Rispetto delle norme deontologiche; concorso alla governance
Responsabilità clinica	Medico e psicologo	Ruoli invariati; l'IA è strumento di supporto
IA e dispositivi	AI Act, dispositivi medici, protezione dei dati	Marcatura CE; supervisione umana; validazione periodica
Governance dell'IA	Comitato etico-scientifico	Monitoraggio dei bias; trasparenza; non discriminazione
Equità digitale	Canali paralleli; supporto multilingue	Alternativa in presenza sempre garantita
Protezione dei dati	Crittografia; pseudonimizzazione	Consenso modulare; collaborazione con il Garante

Tabella H.2. Il quadro della conformità organizzativa e di governance dell'intervento.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d'eccellenza al servizio strutturato

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Scienza dell'implementazione, dispiegamento, casi commerciale e gestionale, sostenibilità finanziaria

Settimo dominio dell'HTA · il profilo organizzativo

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Le parti precedenti hanno mostrato che l'intervento è efficace, efficiente, equo e legittimo; questa parte affronta la domanda decisiva per il decisore: è attuabile e sostenibile. La fattibilità è trattata con gli strumenti della scienza dell'implementazione, e la sostenibilità con i casi commerciale, gestionale e finanziario del modello di valutazione degli investimenti pubblici. La parte presenta i quadri della scienza dell'implementazione (capitolo I.1); disegna il dispiegamento del servizio (I.2); definisce il caso commerciale, ossia il modello contrattuale e la tariffa (I.3); il caso gestionale, ossia la governance e i rischi (I.4); e il caso finanziario, ossia la sostenibilità e le coperture (I.5). Per l'Emilia-Romagna, la maturità della rete, l'ampia disponibilità di professionisti e la solidità del bilancio rendono l'attuazione particolarmente agevole.

I.1 La scienza dell'implementazione

L'attuazione è trattata con il rigore della scienza dell'implementazione, e non lasciata all'improvvisazione.^[1127]
^{[1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141][1142]} Due quadri complementari ne governano l'analisi. Il modello RE-AIM misura la riuscita e la validità esterna dell'attuazione lungo cinque dimensioni — portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento.^[1143] Il quadro consolidato per la ricerca sull'implementazione ne spiega invece i determinanti, articolati in cinque domini, consentendo di

individuare in anticipo barriere e facilitatori.^[1144] Da questi quadri lo studio deriva i determinanti che seguirà: il tasso di copertura, l'adozione delle sedi, la fedeltà al modello, i tempi di attivazione, il numero di psicologi reclutati e formati e il grado di integrazione nei flussi di lavoro.^[1145] La tabella seguente riepiloga i due quadri.

Dimensione	Che cosa misura o spiega
Portata (RE-AIM)	Quota della popolazione bersaglio raggiunta
Efficacia (RE-AIM)	Esiti clinici e di sistema effettivamente conseguiti
Adozione (RE-AIM)	Adesione delle sedi e dei professionisti
Implementazione (RE-AIM)	Fedeltà al modello e qualità dell'attuazione
Mantenimento (RE-AIM)	Sostenibilità del servizio nel tempo
Determinanti (quadro CFIR)	Innovazione, contesto esterno e interno, individui, processo

Tabella I.1. I quadri della scienza dell'implementazione: RE-AIM per gli esiti, CFIR per i determinanti.

I.2 Il disegno del dispiegamento

Il servizio è dispiegato in modo scaglionato: le otto Aziende USL passano in sequenza, per fasi semestrali, dalla condizione di controllo a quella di intervento, a partire dalle aziende di maggiore dimensione e prontezza, sino a coprire l'intera regione, secondo un ordine definito dalla Giunta su criteri trasparenti e con il coordinamento unitario della Regione.^[1146] Questo disegno assolve una doppia funzione: organizzativa, perché consente un avvio graduale compatibile con i tempi del reclutamento e della formazione; e valutativa, perché la successione configura un esperimento naturale che fonda la valutazione controfattuale d'impatto della Parte L.^[1147] Il reclutamento, a fronte di un fabbisogno di circa 970 psicologi, avviene tramite elenco aziendale e rapporto convenzionale, valorizzando in prima applicazione l'esperienza maturata nei progetti aziendali già attivi — un punto di forza dell'Emilia-Romagna, che dispone di un'ampia base di professionisti e di esperienze consolidate.^[1148] Il cronoprogramma procede per fasi semestrali, con il monitoraggio che accompagna l'intero arco e prosegue oltre il completamento.^[1149] Tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% in fase di attuazione, che il monitoraggio è chiamato a verificare sui dati regionali.^[1150] La tabella seguente espone le fasi.

Fase del dispiegamento	Contenuto
Fase 1 (primo semestre)	Avvio nelle Aziende USL di maggiore dimensione e prontezza; reclutamento e formazione iniziali
Fasi 2-8 (semestri successivi)	Estensione progressiva alle altre Aziende USL; attivazione scaglionata secondo l'ordine definito
Fase finale (completamento)	Copertura dell'intero territorio regionale
Attività trasversale	Monitoraggio e valutazione, che proseguono oltre il completamento del dispiegamento

Tabella I.2. Le fasi del dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Aziende USL.

I.3 Il caso commerciale: il modello contrattuale e la tariffa

Il caso commerciale riguarda la fattibilità dell'assetto contrattuale. Esso poggia su un rapporto convenzionale ancorato all'accordo della specialistica ambulatoriale, da cui discende un costo medio per incarico dell'ordine di 55.000 euro l'anno e i tre scenari di spesa — 27, 40 e 53 milioni — già esposti nella Parte E. Il modello dell'elenco aziendale e del rapporto convenzionale è già adottato da altre Regioni, non richiede la creazione di nuove figure professionali e, in Emilia-Romagna, può avvalersi dell'esperienza convenzionale già consolidata nelle cure primarie.^[1151]

I.4 Il caso gestionale: la governance e i rischi

Il caso gestionale riguarda la governance e i rischi. L'attuazione è governata su due livelli: a livello regionale, un comitato di indirizzo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, le Aziende USL, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli Istituti di ricovero e cura, l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, la medicina generale, la pediatria di libera scelta e le università regionali, ed è affiancato dall'Osservatorio regionale previsto dalle proposte di legge; a livello aziendale, ciascuna Azienda USL è responsabile dell'attuazione nel proprio ambito, secondo l'indirizzo unitario della Regione.^[1152] I rischi attuativi principali — reclutamento insufficiente, debole adesione della medicina generale, interoperabilità incompleta, disomogeneità territoriale e venir meno delle coperture — sono associati a misure di mitigazione dedicate, e il dispiegamento graduale è esso stesso la principale forma di mitigazione, poiché consente di osservare e correggere prima dell'estensione.^[1153] La tabella seguente riepiloga rischi e misure.

Rischio	Natura	Misura di mitigazione
Reclutamento insufficiente	Carenza di psicologi formati	Dispiegamento graduale; formazione anticipata e scaglionata
Adesione della medicina generale	Integrazione debole nel percorso	Protocolli di invio; formazione congiunta; governance condivisa
Sistemi informativi	Interoperabilità incompleta	Cartella interoperabile; standard nazionali; raccordo regionale
Disomogeneità territoriale	Attuazione diseguale tra Aziende USL	Algoritmo allocativo; indirizzo regionale; monitoraggio per area
Venir meno delle coperture	Fragilità finanziaria	Istituzionalizzazione; copertura ordinaria su bilancio prossimo al pareggio

Tabella I.3. I rischi attuativi e le relative misure di mitigazione.

I.5 La sostenibilità finanziaria e le coperture

Il caso finanziario riguarda le coperture e la sostenibilità. Le fonti comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, superiore ai dieci miliardi di euro, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'infrastruttura territoriale e digitale, e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali.^[1154] Il vincolo di bilancio non è stringente: con conti prossimi al pareggio e in assenza di piano di rientro, il

costo del servizio, anche a massima copertura, costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale del finanziamento, agevolmente assorbibile, sicché la sostenibilità è in Emilia-Romagna più immediata che nelle regioni in difficoltà.^[1155] Nel lungo periodo, la sostenibilità è assicurata dalla modestia del costo, dal forte ritorno sociale, dall'istituzionalizzazione già in itinere e dalle economie di scala del coordinamento regionale.^[1156] Resta ferma la cautela metodologica già dichiarata: i risultati italiani provengono in parte da letteratura grigia e i benchmark esteri richiedono adattamento, sicché la verifica empirica sui dati regionali, prevista dalla Parte L, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate.^[1157] Dimostrate l'attuabilità e la sostenibilità, la parte che segue definisce il sistema di monitoraggio e di valutazione ex post.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d'eccellenza al servizio strutturato

Parte L

Monitoraggio, valutazione ed ex post

Sistema di indicatori, protocollo e baseline, valutazione controfattuale, verifica ex post, indicatori compositi

Verifica ex post · esperimento naturale e clausola valutativa · fondamento empirico delle stime

Parte L — Monitoraggio, valutazione ed ex post

Questa parte organizza la misurazione dell'intervento nel tempo, ed è il passaggio che distingue una riforma argumentata da una riforma dimostrata. Essa serve ex post i criteri della griglia di giudizio, chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione e, soprattutto, fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti.^{[1158][1159][1160][1161][1162][1163][1164][1165][1166][1167][1168][1169][1170][1171][1172][1173][1174][1175][1176]} Vale qui una verifica onesta della completezza del progetto, che conduce a una conclusione netta: al progetto non manca un'architettura, ma il radicamento nei dati e l'avvio della misurazione. Le parti seguenti definiscono perciò gli strumenti di questo radicamento: il sistema di indicatori (capitolo L.1), il protocollo che li alimenta e la baseline (L.2), la valutazione controfattuale che ne trae prove causali (L.3), la verifica ex post della norma (L.4) e gli indicatori compositi che ne sintetizzano i risultati nel cruscotto (L.5). Per l'Emilia-Romagna, la successione delle otto Aziende USL offre un esperimento naturale di particolare robustezza.

L.1 Il sistema di indicatori

Il sistema di indicatori è costruito sull'ossatura del modello di Donabedian per la qualità dell'assistenza, che distingue le dimensioni di struttura — le risorse e l'organizzazione — di processo — le attività svolte — ed esito — i risultati di salute — qui integrate da una quarta dimensione, l'impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società.^[1177] Su questa ossatura si dispone una batteria di circa cinquantotto misure, articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti e circa quaranta richiedono la rilevazione diretta del servizio.^[1178] La selezione delle misure non è arbitraria, ma orientata dal principio della parsimonia: l'iniziativa internazionale per i set di esiti essenziali e i relativi standard individuano, mediante consenso strutturato, un nucleo condiviso e parsimonioso di esiti, evitando la proliferazione di misure ridondanti.^[1179] Misurare molto non equivale a misurare bene. La tabella seguente riepiloga le otto categorie e lo stato della rispettiva baseline.^[1180]

Categoria	Esempi di indicatori	Baseline
Bisogno e domanda	Prevalenza del disagio, utenza dei servizi, accessi impropri	Disponibile
Accesso ed equità	Tempo di attesa, copertura, divari tra Aziende	Da rilevare
Processo	Sedute erogate, cicli completati, abbandoni	Da rilevare
Esito clinico	Recupero, miglioramento affidabile, mantenimento	Da rilevare
Economici	Risparmi per canale, costo per esito	Misto
Impatto sociale	Produttività, benessere, indicatori territoriali	Misto
Organizzativi	Reclutamento, formazione, fedeltà al modello	Da rilevare
Variabili di sintesi	Indici compositi di esito e di valore	Da calcolare

Tabella L.1. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline. Circa quaranta indicatori richiedono la rilevazione diretta del servizio.

L.2 Il protocollo di rilevazione e la baseline

Perché gli indicatori siano calcolabili occorre un protocollo di rilevazione, ed è questo l'elemento operativo che colma la lacuna di attivazione della misurazione. Il protocollo è minimo — deliberatamente essenziale, per non gravare sull'attività clinica — e attivo dal primo giorno: si registrano la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni.^[1181] Gli strumenti di esito sono validati e di uso internazionale: il questionario sulla salute del paziente a nove voci e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci, impiegati — si ribadisce — nei soli punteggi complessivi.^[1182] La scelta di raccogliere le misure a ogni seduta, e non solo all'inizio e alla fine, segue il modello dei programmi inglesi: è ciò che consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non protrarre percorsi inefficaci.^[1183]

Alla rilevazione si lega la costituzione della baseline, ossia la fotografia dello stato di partenza senza la quale nessun effetto sarebbe misurabile. La baseline si costituisce su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti forniscono la fotografia del prima e vanno registrati subito; la rilevazione di servizio parte con il primo assistito. Il principio è stringente, e merita di essere enunciato senza attenuazioni: ogni mese di ritardo nell'avvio della rilevazione è un mese di dati di base perduti, non recuperabili a posteriori.^[1184] Il calendario disciplina questa sequenza, dalla costituzione della baseline prima dell'avvio, alla registrazione corrente dall'avvio, alla trasmissione mensile di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale, fino al calcolo periodico delle misure di sintesi e all'aggiornamento del cruscotto.^[1185] La tabella seguente lo riepiloga.

Momento	Attività
Prima dell'avvio (per area)	Costituzione della baseline con i dati disponibili; predisposizione del registro e dei questionari
All'avvio	Inizio della registrazione di ogni presa in carico e di ogni seduta, con i punteggi di esito
In continuo	Alimentazione del registro; trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale con cadenza mensile
Periodico (semestrale e annuale)	Calcolo delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale

Tabella L.2. Il calendario della rilevazione. La baseline da statistiche correnti precede l'avvio; la rilevazione di servizio parte con il primo assistito.

L.3 La valutazione controfattuale

Il monitoraggio continuo dice se gli indicatori migliorano; non dice, da solo, se a migliorarli sia stato l'intervento. A questa domanda risponde la valutazione controfattuale d'impatto, che misura l'effetto causale confrontando gli esiti dei trattati con il controfattuale — ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente. Lo strumento che rende possibile questa stima è, in questo studio, lo stesso disegno del dispiegamento: la sua scansione scaglionata tra le otto Aziende configura un esperimento naturale, idoneo a misurare gli effetti reali del servizio.^[1186] Il metodo principale è la differenza-nelle-differenze, che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le Aziende già attivate e quelle non ancora attivate, sotto l'ipotesi di andamento parallelo; a esso si affianca il controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata di unità non trattate.^[1187]

L'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e l'effetto medio sui soli trattati, e la sua solidità dipende dalla validità interna — la garanzia che l'effetto sia realmente attribuibile all'intervento e non a tendenze generali — mentre la validità esterna va valutata a parte; i disegni a esperimento naturale sono, per gli interventi di salute della popolazione, lo strumento raccomandato dalla letteratura metodologica.^[1188] La portata di questo metodo, per il presente studio, è dirimente: confrontando, ad esempio, l'andamento degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche nelle Aziende che hanno attivato il servizio con quello delle Aziende che lo attiveranno, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata.^[1189] È questo il passaggio che, a regime, eleva lo studio da proposta argomentata a politica validata, e che chiude il cerchio aperto dal valore dell'informazione della Parte F.

L.4 La verifica ex post della norma

La misurazione tecnica si salda al ciclo della regolamentazione mediante la verifica ex post. La verifica dell'impatto della regolamentazione, disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017, è valutazione ex post — di norma dopo un biennio — dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, e chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione: l'una stima ex ante gli effetti attesi, l'altra ne accerta ex post il conseguimento.^[1190] A essa si lega, sul piano regionale, la clausola valutativa, che impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti. La clausola è il

passaggio che lega la misurazione tecnica alla responsabilità politica e alla trasparenza verso il legislatore regionale: i risultati non restano negli archivi amministrativi, ma sono portati periodicamente all’attenzione dell’organo che ha disposto il servizio, a presidio della rendicontazione democratica.^[1191]

L.5 Gli indicatori compositi e il cruscotto

L’ultima funzione del sistema è la sintesi. La molteplicità degli indicatori, necessaria all’analisi, sarebbe però di difficile lettura per il decisore: gli indicatori compositi riducono tale molteplicità a poche misure di valore complessivo, secondo un metodo codificato. Il manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione delle variabili alla normalizzazione, alla ponderazione e all’analisi di robustezza.^[1192] L’impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica ha del resto un precedente istituzionale italiano nel Benessere Equo e Sostenibile, i cui indicatori sono entrati, con la riforma del bilancio del 2016, nel ciclo della programmazione economica.^[1193] La costruzione degli indici compositi è retta da regole di coerenza e di non duplicazione: il divieto di doppia contabilizzazione impone che una grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali già adottata nella Parte E.^[1194] Il cruscotto regionale, aggiornato periodicamente, restituisce in forma sintetica le dimensioni essenziali — il guadagno di salute, il tasso di recupero, il ritorno sociale, l’equità territoriale, la riduzione delle liste di attesa e gli indicatori di sistema — in luogo del canale della mobilità recuperata, non pertinente all’Emilia-Romagna. La tabella seguente ne riepiloga le dimensioni.

Dimensione di sintesi	Contenuto
Guadagno di salute	Anni di vita ponderati per la qualità in salute mentale
Tasso di recupero	Miglioramento clinico e superamento delle soglie (PHQ-9, GAD-7)
Ritorno sociale	Valore sociale generato per euro investito (SROI)
Equità territoriale	Esito e accesso tra Aziende USL e tra aree di pianura e di Appennino
Liste di attesa	Riduzione dei tempi di attesa e completamento della rete territoriale
Indicatori di sistema	Esito, esperienza, costo e operatori (Quadruple Aim)

Tabella L.3. Le dimensioni di sintesi del cruscotto regionale emiliano-romagnolo.

Definiti gli strumenti della misurazione, lo studio dispone di tutto l’occorrente per accertare nel tempo gli effetti della riforma. La Parte M ne ricompone i risultati in una valutazione multidimensionale e formula le raccomandazioni conclusive.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d’eccellenza al servizio strutturato

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Griglia OCSE-DAC, analisi multi-criterio, sintesi del valore e raccomandazioni, limiti e agenda di ricerca

Sintesi conclusiva · caso strategico del Five Case Model · griglia di giudizio OCSE-DAC

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa è la parte conclusiva dello studio, e ha una funzione diversa da tutte le precedenti: non aggiunge una nuova analisi, ma ordina quelle già svolte in un giudizio. Lo strumento di questo giudizio è la griglia dei criteri dell’OCSE-DAC, che attraversa l’intero studio come metro di valutazione e converge qui nella sintesi; la parte fornisce inoltre il contenuto del caso strategico del Five Case Model.^{[1195][1196][1197][1198][1199][1200][1201][1202][1203][1204][1205][1206][1207][1208][1209][1210]} Le precedenti cornici del telaio dicono che cosa valutare, come decidere e come riportare l’economia; mancava la griglia rispetto alla quale l’intervento è infine giudicato, e la parte la applica (capitolo M.1), la integra con l’analisi multi-criterio per i criteri non monetari (M.2), ne ricava una sintesi del valore e raccomandazioni per il decisore (M.3) e ne dichiara, con franchezza, i limiti e l’agenda di ricerca (M.4).

M.1 La griglia di valutazione OCSE-DAC

I criteri dell’OCSE-DAC sono sei lenti complementari che, insieme, danno un quadro complessivo dell’intervento e dei suoi risultati: la rilevanza rispetto al bisogno, la coerenza con le altre politiche, l’efficacia nel raggiungere gli obiettivi, l’efficienza nell’uso delle risorse, l’impatto più ampio e la sostenibilità nel tempo.^[1211] Essi operano in due momenti dello studio: ex ante orientano la valutazione complessiva, poiché ciascun criterio diventa una domanda a cui le parti analitiche forniscono la risposta; ex post strutturano la verifica dei risultati, già trattata nella Parte L. La griglia, in tal modo, non si sovrappone all’analisi economica o ai domini della valutazione di tecnologia sanitaria, ma li ordina in un giudizio.

Applicata a questo studio, la griglia restituisce un giudizio convergente, con una sola qualificazione, propria del caso emiliano-romagnolo, sul criterio dell’efficienza. L’intervento è rilevante, perché risponde a un bisogno reale e di grande dimensione e all’obbligo di garantire i livelli essenziali;^[1212] è coerente, perché compatibile con gli standard dell’assistenza territoriale, con il PNRR e con gli atti regionali che già ne prevedono la funzione, ed è costituzionalmente difendibile, senza incontrare il vincolo del piano di rientro;^[1213] è efficace, perché l’evidenza internazionale ne documenta il raggiungimento degli obiettivi clinici;^[1214] è efficiente in termini di costo-utilità, con dominanza per paziente, pur a fronte di un saldo diretto negativo sul solo bilancio, di entità modesta;^[1215] ha un impatto distributivo favorevole e un ritorno complessivo di 3,8-5,5 a uno;^[1216] ed è sostenibile, sul piano finanziario e organizzativo.^[1217] La tabella seguente riepiloga il giudizio, criterio per criterio.

Criterio	Domanda valutativa	Giudizio dallo studio
Rilevanza	Risponde al bisogno reale?	Sì: ~890.000 con disagio inevaso; obbligo dei livelli essenziali
Coerenza	È compatibile con le altre politiche?	Sì: DM 77, PNRR, atti regionali (deliberazioni 2021 e 2023); difendibile in Costituzione; nessun piano di rientro
Efficacia	Raggiunge gli obiettivi?	Sì: evidenza internazionale (recupero ~50%)
Efficienza	Impiega le risorse in modo proporzionato?	Sì in costo-utilità (dominanza); saldo diretto negativo a costo modesto
Impatto	Produce effetti più ampi?	Sì: riduce il gradiente territoriale; ritorno complessivo 3,8-5,5:1
Sostenibilità	I benefici e il servizio durano?	Sì: costo modesto, bilancio in riequilibrio, rete territoriale già matura

Tabella M.1. La griglia di giudizio OCSE-DAC applicata allo studio, criterio per criterio.

M.2 L'analisi multi-criterio

L'analisi costo-efficacia e l'analisi del ritorno sociale esprimono il valore in termini prevalentemente monetari. La decisione pubblica, tuttavia, contempera una pluralità di criteri, alcuni dei quali non riducibili a denaro: l'equità, la fattibilità, la coerenza con gli indirizzi strategici, la solidità dell'evidenza. L'analisi multi-criterio rende esplicito questo bilanciamento, attribuendo a ciascun criterio un peso e a ciascuna opzione un punteggio, e aggregandoli in un punteggio complessivo.^[1218] È il metodo che impedisce alla decisione di ridursi alla sola dimensione economica, e che al tempo stesso ne rende trasparente la logica, poiché i pesi e i punteggi sono dichiarati e sindacabili.

Il confronto è condotto tra l'opzione di intervento e l'opzione zero — il mantenimento dello status quo — su otto criteri pesati. Il risultato è netto: l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 81,45 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri a eccezione della sola fattibilità immediata, nella quale l'opzione zero — che non richiede alcuna attuazione — è ovviamente superiore, ma il cui svantaggio è gestito attraverso il dispiegamento graduale.^[1219] Rispetto al caso pugliese, nel quale il saldo diretto è positivo, il punteggio dell'intervento è lievemente inferiore, in ragione del saldo diretto negativo che riduce il sub-punteggio dell'impatto di bilancio; la maggiore maturità della rete territoriale emiliano-romagnola ne innalza tuttavia il sub-punteggio di fattibilità rispetto agli altri contesti a saldo diretto negativo. Resta una preferenza netta e stabile rispetto ai pesi adottati. La tabella seguente riporta la matrice delle prestazioni.

Criterio	Peso	Interv.	Opz. zero	Δ pond.
Efficacia clinica	15%	80	30	+7,5
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	88	25	+12,6
Impatto di bilancio e sostenibilità	15%	70	50	+3,0
Equità e accesso (Appennino, stranieri, liste di attesa)	15%	85	20	+9,75
Valore sociale	10%	88	20	+6,8
Fattibilità e implementabilità	10%	78	100	-2,2
Robustezza dell'evidenza	10%	75	60	+1,5
Coerenza strategica (DM 77, PNRR, atti regionali)	5%	90	25	+3,25
Punteggio complessivo ponderato	100%	81,45	39,25	+42,20

Tabella M.2. Analisi multi-criterio: confronto tra l'*****opzione di intervento e l'*****opzione zero su otto criteri pesati.

M.3 La sintesi del valore e le raccomandazioni

La sintesi del valore si lascia condensare in tre affermazioni, che costituiscono il cruscotto decisionale della riforma in Emilia-Romagna. La prima: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, dell'ordine di alcune decine di milioni, trascurabile rispetto a un

finanziamento dell'ordine di dieci miliardi. La seconda: il ritorno per la collettività è ampio, con un rapporto beneficio-costi dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. La terza: il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali — la produttività, il funzionamento, il minor carico familiare — e non sul risparmio per il bilancio.^[1220] È questa la corretta rappresentazione della proposta emiliano-romagnola: non un investimento che si ripaga sui conti sanitari, ma un investimento sociale ad alto rendimento, il cui costo per il bilancio è trascurabile.

Da questa sintesi discende la raccomandazione centrale, ed è in essa che il caso emiliano-romagnolo si distingue da quello delle regioni dotate di una legge regionale dedicata. La decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già diffusa in numerose Aziende USL attraverso atti amministrativi regionali, le deliberazioni di Giunta del 2021 e del 2023, e progetti aziendali consolidati da oltre un decennio — ma se strutturarla, dimensionarla e istituzionalizzarla, portandola dalla diffusione amministrativa, oggi frammentaria e diseguale tra i territori, alla copertura sistematica del fabbisogno, dell'ordine di 730 incarichi nello scenario di base.^[1221] La sintesi del valore è letta, infine, lungo le cinque dimensioni del Quintuple Aim — l'esito di salute, l'esperienza della persona, il costo, il benessere degli operatori e l'equità — che ricompongono in un quadro unitario i risultati delle parti analitiche.^[1222] La raccomandazione operativa è di procedere per gradi, secondo il dispiegamento scaglionato tra le otto Aziende USL, avviando contestualmente la rilevazione e la valutazione controfattuale, in modo che ogni fase di estensione sia informata dai risultati della precedente.

M.4 I limiti e l'agenda di ricerca

La credibilità di una valutazione si misura anche dalla franchezza con cui ne dichiara i limiti. Il limite principale di questo studio è il radicamento nei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione emiliano-romagnola, pari al 7,5%, e non estratte dai conti regionali certificati. È una distinzione che lo studio dichiara apertamente, perché la sostituzione di tali ricostruzioni con i valori certificati delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere-Universitarie è la condizione per la presentazione della proposta agli organi di controllo.^[1223] A esso si aggiungono cautele di trasferibilità e di fonte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la cifra del ritorno è inoltre prudenziale e non ponderata per l'equità, e potrebbe perciò risultare conservativa.^[1224]

Da questi limiti discende l'agenda di ricerca. L'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere-Universitarie, seguito dall'avvio della rilevazione di servizio e dalla valutazione controfattuale sul dispiegamento scaglionato tra le otto Aziende.^[1225] È il programma che trasforma progressivamente la proposta argomentata in politica validata, e che salda la valutazione ex ante alla verifica ex post. Con questa parte si chiude lo studio regionale emiliano-romagnolo, che applica al contesto dell'Emilia-Romagna, con piena fedeltà metodologica e con le dovute qualificazioni di onestà, il medesimo telaio integrato già adottato per la Puglia, per la Lombardia e per il Veneto: un intervento clinicamente fondato, economicamente sostenibile, equo e attuabile, il cui valore per la collettività è ampio e il cui costo per il bilancio è trascurabile, e la cui maturità organizzativa candida l'Emilia-Romagna a fungere da modello nazionale per la strutturazione del servizio.

STUDIO REGIONALE · REGIONE EMILIA-ROMAGNA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal modello territoriale d'eccellenza al servizio strutturato

Appendici A-E

Corredo tecnico e documentale

Caso di riferimento, strumenti di esito, dati regionali, standard di reporting, glossario

Materiali a sostegno delle Parti da A a M

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l’orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità.^{[1226][1227][1228][1229][1230][1231][1232][1233][1234]} La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Servizio attuale o assenza del servizio a regime
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Azienda USL/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudenziale	Riduzione per l’ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura.^[1235] La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l’analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell’intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l’analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato dell’Emilia-Romagna, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.^[1236] La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 490	~ 730	~ 960
Costo del servizio	~ 27	~ 40	~ 53
Risparmi diretti (SSR)	~ 16	~ 27	~ 40
Ricadute economico-sociali	~ 86	~ 160	~ 250
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -11	~ -13	~ -13
Saldo complessivo (caso economico)	+75	+147	+237
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,8:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell’esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario.^[1237] La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d’ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura.^[1238] La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori emiliano-romagnoli impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.^[1239]

Ambito	Valore regionale
Popolazione regionale	4.451.938 abitanti (Censimento ISTAT 2024); popolazione in crescita per saldo migratorio positivo
Finanziamento del SSR	Superiore a 10 miliardi di euro; disavanzo in riduzione e coperto dalla Regione; nessun piano di rientro
Mobilità sanitaria	Saldo fortemente attivo, dell'ordine di +525 milioni; regione tra le prime creditrici d'Italia
Pronto soccorso	~ 1.400.000 accessi/anno
Farmaceutica	Consumo regionale delle categorie dei psicofarmaci
Salute mentale	~ 890.000 con disagio comune; ~ 66.000 in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale
Funzione attuale	Esperienze strutturate dal 2015 (Azienda USL di Bologna); DGR 1141/2021 e 2185/2023; funzione diffusa per via amministrativa ma non istituzionalizzata; ~ 5% del fabbisogno

Tabella C.1. I valori regionali di ancoraggio dell'Emilia-Romagna.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione emiliano-romagnola, e non estratti dai conti regionali certificati.^[1240] La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Azienda USL e per area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[1241] La tabella seguente li riepiloga.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.^[1242] Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra trattati e non trattati
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità non trattate
Dispiegamento scaglionato	Attivazione progressiva che rende le aree non ancora coperte gruppo di confronto

Termine	Definizione
Analisi e verifica d’impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta a riferire al Consiglio sui risultati della riforma
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell’implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall’impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d’ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l’intensità dell’intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; in Emilia-Romagna il saldo è fortemente attivo, dell’ordine di +525 milioni
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di concentrazione	Misura che lega l’esito di salute alla posizione socio-economica
Peso morto	Quota dell’esito che si sarebbe verificata anche senza l’intervento

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

Blocco Regionale II — Italia centrale

Toscana — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Toscana

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione Toscana sulla riforma «Psicologo di Base». Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell'intero corpus: la premessa, l'indice generale di tutte le parti e di tutte le appendici, la mappa di integrazione delle cornici metodologiche e la sintesi del valore. La Toscana occupa, nel panorama nazionale, la posizione giuridicamente più avanzata: è tra le poche Regioni ad aver istituito il servizio di psicologia di base con una legge regionale dedicata — la legge 15 novembre 2022, n. 39, attuata con il regolamento di cui alla deliberazione 43 del 2024 — e ne ha avviato la sperimentazione dal settembre 2024, estendendola progressivamente a tutte e tre le Aziende USL. Nei primi diciotto mesi la sperimentazione ha preso in carico circa 2.300 cittadini in ventuno strutture, con valutazione positiva, ma su base libero-professionale e a copertura di una frazione ridotta del fabbisogno. La decisione rilevante non è dunque se introdurre il servizio, né se dotarlo di una legge, già esistente, ma se portarlo dalla sperimentazione alla strutturazione a regime e dimensionarlo, dando forma stabile e duratura a una funzione già istituita e praticata.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell'intero corpus, che può essere percorso nell'ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.3	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, costo-efficacia distributiva, divari territoriali
Parte H	H.1-H.3	Profili etico, giuridico e organizzativo: etico, costituzionale, organizzativo e conformità
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: implementazione, dimensionamento, casi commerciale e gestionale, sostenibilità
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio, valutazione ed ex post: indicatori, protocollo, controfattuale, verifica ex post, cruscotto
Parte M	M.1-M.4	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: griglia OCSE-DAC, analisi multi-criterio, raccomandazioni, limiti
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati regionali e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — lievemente negativo per la Toscana, regione con un sistema già efficiente, un livello essenziale di assistenza elevato e un saldo di mobilità nettamente attivo, sicché il canale del recupero della mobilità è inapplicabile come leva di risparmio — e il saldo complessivo, ampiamente positivo. La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 22	~ 33	~ 44
Risparmi diretti (SSR)	~ 14	~ 22	~ 34
Ricadute economico-sociali	~ 71	~ 133	~ 207
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -8	~ -11	~ -10
Saldo complessivo (caso economico)	+63	+122	+197
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante non è se prevedere il servizio — già istituito dalla legge regionale 39 del 2022 e attivo in via sperimentale — né se dotarlo di una legge, già esistente, ma se portarlo dalla sperimentazione alla strutturazione a regime, con un rapporto convenzionale analogo a quello dei medici di medicina generale a superamento degli incarichi libero-professionali, e dimensionarlo, portandolo dalla copertura attuale, dell'ordine del 5% del fabbisogno, alla copertura sistematica, dell'ordine di 790 incarichi nello scenario espansivo. Il limite principale è il radicamento dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione toscana, del 6,2%, e non estratte dai conti regionali certificati delle tre Aziende USL e delle quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie; la loro sostituzione con dati certificati è la condizione per la presentazione agli organi di controllo, ed è in Toscana agevolata dalla disponibilità dei dati della sperimentazione già attiva.

Lo studio si fonda, sul piano comparativo, sui programmi internazionali più autorevoli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie — il programma inglese di terapie psicologiche, il modello olandese, l'iniziativa australiana e il Collaborative Care statunitense — dei quali mutua le evidenze di efficacia e di costo-efficacia, adattandole con cautela al contesto toscano. La combinazione, propria della Toscana, di una legge regionale già vigente, di una sperimentazione attiva con dati di esito propri e di una struttura amministrativa consolidata in sole tre Aziende USL ne fa una candidata naturale a fungere da riferimento nazionale per la fase di strutturazione a regime e di implementazione uniforme, anche per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel percorso assistenziale. Su questa base, e con la dichiarazione trasparente dei propri limiti, il corpus consegna al decisore un quadro completo e onesto su cui deliberare.

STUDIO REGIONALE · REGIONE TOSCANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell'HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per la Toscana, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna e al Piemonte. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati alla Toscana. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). È la parte che rende lo studio insieme rigoroso, riproducibile e confrontabile con quelli pugliese, lombardo, veneto, emiliano-romagnolo e piemontese e con quelli delle altre Regioni.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Servizio di Psicologia di Base nelle cure primarie della Toscana, inteso come strutturazione a regime di una funzione che la regione ha già istituito con una legge dedicata — la legge regionale 39 del 2022 — e reso operativo in via sperimentale dal settembre 2024, nelle Case della Comunità e in integrazione con la medicina generale, con esiti positivamente valutati e circa 2.300 cittadini che hanno avviato un percorso nei primi diciotto mesi.^[1243] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sul portare il servizio a regime. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già istituita per legge e operante — ma se darle dimensione e stabilità: l'esperienza sperimentale esiste e produce numeri verificabili, ma la stabilizzazione del rapporto, l'estensione a tutte le Case della Comunità e una copertura adeguata al fabbisogno sono ancora da definire, a fronte di un fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 790 psicologi. Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 730.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale, in un quadro segnato da componenti convergenti — il bisogno dell'età anziana, marcato in una delle regioni più anziane d'Italia e accentuato nelle aree interne e montane, il disagio connesso al lavoro nella popolazione attiva, il disagio giovanile e una rilevante dimensione multiculturale — cui si aggiunge la pressione delle liste di attesa. La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti toscani con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è lo psicologo di base nelle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, portato a regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale il servizio è già istituito per legge e operante in via sperimentale su base libero-professionale, ma non ancora strutturato a regime né dimensionato al fabbisogno. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario della Toscana, con le sue tre Aziende USL, le quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, l'ente regionale di supporto tecnico-amministrativo e la rete delle Case della Comunità e delle Case della Salute. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per la Toscana
Popolazione	Residenti toscani con disagio psichico comune (~730.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Psicologo di base nelle cure primarie, primo livello e filtro, portato a regime (~400/600/790 incarichi); strutturazione e dimensionamento del servizio già istituito per legge e sperimentato
Confronto	Condizione attuale: servizio istituito con la legge regionale 39 del 2022 e operante in via sperimentale dal settembre 2024 su base libero-professionale, in ventuno strutture, dimensionato a una frazione del fabbisogno
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale della Toscana; tre Aziende USL, quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, ente regionale di supporto tecnico-amministrativo, tre Aree Vaste, rete delle Case della Comunità e delle Case della Salute

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell'HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell'OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l'intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e il servizio attuale come comparatore. Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Aziende USL, le Aree Vaste e le zone-distretto, per dare conto anche dei divari territoriali interni.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale, ovvero servizio istituito per legge e operante in via sperimentale su base libero-professionale, non strutturato a regime né dimensionato
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda USL, Area Vasta e zona-distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. Tale prudenza assume, per la Toscana, un rilievo particolare e di segno definito: il saldo di mobilità sanitaria è nettamente attivo, dell'ordine di 58 milioni di euro, e colloca la regione tra le più attrattive d'Italia, trainata dalle grandi Aziende Ospedaliero-Universitarie. Poiché la regione è già creditrice, e l'attrazione riguarda la specialistica e il ricovero più che la domanda psicologica, il canale del recupero della mobilità non costituisce qui una leva di risparmio. Ne consegue che il saldo diretto risulta lievemente negativo e che il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, che lo studio stima con criteri conservativi; in un contesto di pressione finanziaria e di liste di attesa, peraltro, il contenimento della domanda impropria conserva una salienza diretta. Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati, benché in Toscana la lacuna sia mitigata dai dati operativi della sperimentazione.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post. Per la Toscana il disegno controfattuale assume una forma propria e particolarmente favorevole: poiché il servizio è già attivo in forma sperimentale e si è esteso in modo scaglionato tra le strutture, l'effetto causale va stimato dal confronto prima-dopo l'attivazione del 2024, dalla progressione per cunei tra le sedi e dall'eterogeneità dell'intensità di copertura, con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico. La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, le tre Aziende USL, le quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, l'Organismo Toscano di Governo Clinico, l'ente regionale di supporto tecnico-amministrativo, l'Ordine degli Psicologi della Toscana, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e le università di Firenze, Pisa e Siena. A differenza del Veneto, la Toscana non dispone di un'azienda regionale unica di coordinamento, ma presenta la struttura più consolidata tra le regioni esaminate: il riordino del 2016 ha accorpato le dodici aziende preesistenti in sole tre grandi Aziende USL, affiancate da un ente regionale di supporto tecnico-amministrativo e da un organismo di governo clinico, sicché il veicolo per una progettazione unitaria e un'attuazione omogenea è robusto. Poiché il servizio è già istituito per legge e operante, e la rete territoriale delle Case della Comunità e delle Case della Salute costituisce l'infrastruttura su cui esso è già innestato, la sfida del governo è di strutturarla e dimensionarla, non di avviarla: è il tratto che distingue la Toscana e che la valutazione assume come punto di partenza.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici; l'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per la loro adozione. Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono

indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto della Toscana.

STUDIO REGIONALE · REGIONE TOSCANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi e cornice normativa

Primo dominio dell'HTA · il problema di salute e il suo contesto

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto della Toscana. La struttura è quella già adottata per la Puglia, per la Lombardia, per il Veneto, per l'Emilia-Romagna e per il Piemonte, e mutano soltanto i dati, ancorati alla regione. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall'epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l'intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico della Toscana: non un sistema da introdurre ex novo, né un servizio operante senza una legge, ma un servizio già istituito da una legge regionale dedicata e avviato in via sperimentale, che attende di essere portato a regime e dimensionato al fabbisogno.

B.1 Quadro demografico

La Toscana conta 3.657.716 residenti, pari a circa il 6,2% della popolazione nazionale, in lieve calo, e presenta una popolazione segnata da un marcato invecchiamento e da bassa natalità, con un saldo naturale negativo solo in parte compensato dal saldo migratorio. L'aspettativa di vita, dell'ordine degli ottantatré anni, è in linea con la media nazionale, ma la struttura per età è tra le più anziane del Paese, con proiezioni di marcata contrazione e ulteriore invecchiamento. La componente straniera, pari all'11,8%, è superiore alla media nazionale e costituisce, a differenza di altre regioni, un tratto rilevante del bisogno, con concentrazioni elevate nell'area centrale e segnatamente a Prato. Il territorio si articola in dieci province, con circa metà della popolazione lungo l'asse urbano centrale e una marcata variabilità interna fra quest'area e le aree interne e montane. La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per la Toscana
Popolazione (Censimento 2024)	3.657.716 (~6,2% del totale nazionale); in lieve calo (-0,1%)
Aspettativa di vita	~ 83 anni, in linea con la media nazionale
Età media	~ 50 anni; struttura tra le più anziane d'Italia; over-65 ~ 26%
Componente straniera	11,8% dei residenti, superiore alla media nazionale; Firenze, Prato, Pisa
Articolazione del territorio	Dieci province; ~ metà in Firenze, Pisa e Lucca (48,9%)
Profilo per età	Asse centrale Firenze-Prato-Pisa dinamico; aree interne e montane anziane e in spopolamento
Articolazione sanitaria	Tre Aziende USL, quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, ente regionale di supporto tecnico-amministrativo

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico della Toscana.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale in Toscana è elevato e sospinto dall'invecchiamento. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali sulla popolazione regionale, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell'ordine di 730.000 persone, in larga parte non intercettate dall'offerta strutturata. A questa quota si somma un'utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale dell'ordine di 52.000 persone, in servizi nei quali la figura dello psicologo è strutturalmente carente. Tre componenti orientano la domanda. La prima è il disagio giovanile, in crescita. La seconda è il disagio connesso al lavoro nella popolazione attiva. La terza, e più caratteristica, è il bisogno dell'età anziana, accentuato nelle aree interne e montane. È la combinazione — invecchiamento marcato, aree interne, dimensione multiculturale e un servizio già istituito per legge e sperimentato — a distinguere il fabbisogno toscano. La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche dell'ordine di trentamila l'anno.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone un'offerta che, in Toscana, presenta una fisionomia peculiare: il servizio di psicologia di base è già istituito da una legge regionale dedicata ed è operativo in via sperimentale dal settembre 2024, con numeri di attività verificabili, ma opera su base libero-professionale, in ventuno strutture, e copre una frazione ridotta del fabbisogno. Il fabbisogno a regime è stimato nell'ordine di 790 psicologi, e l'Ordine professionale regionale ne sostiene la strutturazione stabile, a superamento degli incarichi libero-professionali. La copertura attuale è dunque attiva ma ridotta: non l'assenza di un servizio, né una funzione solo amministrativa, ma un servizio reale, fondato su una legge e già sperimentato, da portare a regime e dimensionare. La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per la Toscana
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 730.000 persone
Utenza stimata in carico ai Dipartimenti	~ 52.000
Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche	~ 30.000 l'anno
Offerta territoriale attuale	Servizio istituito per legge (L.R. 39/2022) e operante in via sperimentale dal settembre 2024 in ventuno strutture, su base libero-professionale; ~ 2.300 cittadini in diciotto mesi
Fabbisogno stimato a regime	~ 790 psicologi (750-820)
Copertura attuale del fabbisogno	Attiva ma ridotta, dell'ordine del 5% del bisogno potenziale

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, in Toscana, si articola su più assi specifici. Il primo è la dualità territoriale fra l'area metropolitana centrale, lungo l'asse Firenze-Prato-Pisa, densamente popolata e dotata di poli sanitari di eccellenza, e le aree interne e montane — l'Amiata, la Garfagnana, la Lunigiana — più anziane e soggette a spopolamento, dove l'accesso ai servizi è strutturalmente più difficoltoso. Il secondo è la dimensione multiculturale, che richiede competenza culturale nell'assistenza, particolarmente nell'area pratese. A questi si aggiunge l'asse delle liste di attesa, comune all'intera regione. Su questi assi il servizio di psicologia di base agisce in funzione di equità: avvicina l'offerta alle aree interne mediante la telepsicologia assistita — la sperimentazione ha già mostrato adesione anche nei piccoli centri e nelle zone montane — e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica e contribuisce a contenere i tempi di attesa.

B.5 I servizi e i flussi

Il Servizio sanitario della Toscana dispone di risorse complessive dell'ordine di 8 miliardi di euro; la Regione non è soggetta a un piano di rientro, ma opera, come gran parte delle regioni, sotto pressione finanziaria, con la riduzione delle liste di attesa indicata come priorità e con un Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2024-2026 di recente approvazione. A differenza delle regioni passive, la Toscana presenta un saldo di mobilità nettamente attivo, dell'ordine di 58 milioni di euro, che la colloca tra le più attrattive d'Italia, trainata dalle grandi Aziende Ospedaliero-Universitarie: ne consegue che il canale del recupero della mobilità, centrale per le regioni debitrice del Mezzogiorno, non costituisce qui una leva di risparmio. L'architettura dei servizi poggia sulla struttura più consolidata tra le regioni esaminate — tre grandi Aziende USL accorpate dal 2016, quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, un ente regionale di supporto tecnico-amministrativo e tre Aree Vaste — e su una rete territoriale costituita dalle Case della Comunità del nuovo assetto e dalle preesistenti Case della Salute, su cui il servizio è già innestato. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per la Toscana
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	~ 8 miliardi di euro; non in piano di rientro; oggi sotto pressione finanziaria, con priorità alle liste di attesa
Mobilità sanitaria	Saldo nettamente attivo (~ +58 milioni nel 2023); regione creditrice; canale non pertinente come leva di risparmio
Accessi al pronto soccorso	Dell'ordine di oltre un milione l'anno
Architettura dei servizi	Tre ASL, quattro AOU, ente regionale di supporto, tre Aree Vaste; rete delle Case della Comunità e delle Case della Salute
Margine di azione principale	Liste di attesa, strutturazione e dimensionamento del servizio già istituito per legge, accesso delle aree interne e montane

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice peculiare e, sul piano giuridico, la più avanzata tra quelle esaminate: la Toscana ha già istituito il servizio con una legge regionale dedicata — la legge 39 del 2022 — attuata con un regolamento e fondata sugli indirizzi operativi dell'Organismo Toscano di Governo Clinico, e ne ha avviato e poi esteso la sperimentazione con successive deliberazioni di Giunta. Sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera, il Piano Nazionale per la Salute Mentale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — che ha confermato la competenza regionale in materia — compongono il quadro di riferimento. La decisione rilevante, in questo contesto, non è introdurre la funzione né dotarla di una legge, già esistente, ma portarla dalla sperimentazione alla strutturazione a regime e dimensionarla: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

STUDIO REGIONALE · REGIONE TOSCANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte C

L'intervento e il suo modello

Definizione, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali e formazione

Secondo dominio dell'HTA · la descrizione della tecnologia

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico della Toscana emerge con nettezza: l'intervento non è da introdurre, ma è già istituito per legge e in funzione in via sperimentale, e si tratta di dargli forma stabile a regime e di dimensionarlo.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire. La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria, ossia dell'intercettare prima che il disturbo si cronicizzi. Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell'ordine di 730.000 persone con disagio comune. La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per la Toscana
Bisogno	~ 730.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Psicologo nelle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, particolarmente nella popolazione attiva, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo di base nelle Case della Comunità e nelle Case della Salute, in collaborazione con i medici di medicina generale e secondo gli indirizzi operativi regionali. La Toscana presenta qui una specificità rispetto alle altre regioni: il servizio è già attivo in via sperimentale nelle tre Aziende USL. A differenza del Veneto, la regione non dispone di un'azienda regionale unica, ma presenta la struttura più consolidata tra quelle esaminate — tre grandi Aziende USL accorpate dal 2016 e un ente regionale di supporto tecnico-amministrativo — sicché il coordinamento, l'omogeneità attuativa e le economie di scala sono assicurati dalla Regione, attraverso la sua Direzione competente e l'Organismo Toscano di Governo Clinico. La rete territoriale delle Case della Comunità e delle Case della Salute è l'infrastruttura su cui il servizio è già innestato, e il compito non è crearla ma estenderla e renderla uniforme su tutto il territorio. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su invio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta — nella forma già in atto nella sperimentazione regionale — o l'accesso diretto, una valutazione iniziale, un ciclo di colloqui brevi e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti. Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata.

Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con il fascicolo sanitario elettronico regionale, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. In coerenza con l'assetto di governo descritto, il coordinamento informativo è in capo alla Regione, che ne assicura l'uniformità fra le tre Aziende USL. La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale; su questo terreno la Toscana dispone di un vantaggio peculiare, poiché la sperimentazione già attiva ha prodotto dati di attività verificabili, da consolidare in un flusso strutturato.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale. Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile. L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica. La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, in Toscana, lo strumento per garantire l'accesso nelle aree interne e montane, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza. I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici. La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle aree interne e montane; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso le Università di Firenze, Pisa e Siena; il livello post-universitario specialistico attraverso un corso regionale con attestato dedicato alla psicologia di base e alle cure primarie, comprensivo della competenza per l'età anziana, per le aree interne e della competenza culturale per l'utenza straniera, particolarmente rilevanti nel contesto toscano; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione. A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità, sostenuta dall'infrastruttura informatica regionale. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Università di Firenze, Pisa e Siena
2. Post-universitario specialistico	Psicologia di base e cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, competenza per l'età anziana e culturale	Corso regionale con attestato
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte D

L'efficacia e l'evidenza

Revisione sistematica, qualità dell'evidenza, benchmark internazionali e trasferibilità

Terzo e quarto dominio dell'HTA · l'efficacia clinica e la sicurezza

Parte D — L'efficacia e l'evidenza

Descritto l'intervento nella Parte C, questa quarta parte ne esamina l'efficacia e l'evidenza, secondo il terzo e il quarto dominio della valutazione. La base di prove è in larga misura indipendente dalla regione, poiché attinge alla letteratura internazionale e ai programmi consolidati; ciò che muta è il giudizio di trasferibilità, calibrato sul contesto toscano. La parte presenta la revisione sistematica delle prove (capitolo D.1); ne valuta la qualità con il sistema GRADE (D.2); esamina i benchmark internazionali e italiani (D.3); e discute la trasferibilità al contesto regionale (D.4), dove acquista un rilievo singolare il patrimonio di evidenza locale costituito dalla sperimentazione regionale, fondata su una legge dedicata e già produttiva di dati di esito reale.

D.1 La revisione sistematica

La sintesi delle prove è condotta secondo i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale, con preferenza per le fonti più recenti. Il quadro che ne emerge è solido. Lo studio fondativo del modello collaborativo ha documentato un tasso di risposta di circa il 50% dei pazienti trattati, contro il 19% della cura usuale. Una meta-analisi su cinquantasette studi controllati ha stimato un miglioramento medio dei sintomi depressivi di 0,28 deviazioni standard. Una revisione di quarantadue implementazioni ha rilevato riduzioni dell'ordine del 47% della depressione, del 43% dell'ansia, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. Il programma inglese, su scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno, conferma questi valori con dati reali. Una meta-analisi sulle cure integrate, infine, stima un effetto modesto sul singolo ma clinicamente rilevante sulla popolazione. La tabella seguente sintetizza i principali risultati.

Fonte	Risultato principale
Studio fondativo (JAMA, 2002)	~ 50% dei pazienti con riduzione ≥ 50% dei sintomi a 12 mesi, contro 19% nella cura usuale
Meta-analisi su 57 studi (2012)	Miglioramento medio dei sintomi depressivi di 0,28 deviazioni standard
Revisione su 42 implementazioni (2024)	-47% depressione e -43% ansia a 6 mesi; -34% accessi al PS; -41% ricoveri
Programma inglese, dati reali (2023-2024)	Recupero 50,2%; miglioramento affidabile 67,8%; completezza dei dati > 98%
Meta-analisi sulle cure integrate	Coefficiente standardizzato -0,11 sui sintomi depressivi (clinicamente rilevante su popolazione)

Tabella D.1. *Principali risultati della letteratura sull'*****efficacia dell'*****integrazione psicologica nelle cure primarie.*

D.2 La qualità dell'evidenza

La qualità dell'evidenza, valutata con il sistema GRADE, è da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni, mentre è più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. Una cautela merita di essere dichiarata con franchezza, perché orienta l'intera impostazione economica dello studio: nello stesso studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l'intervallo di confidenza comprende lo zero. Il valore economico del modello, di conseguenza, poggia in misura preponderante sui ritorni sociali e non sui risparmi sanitari diretti. È una cautela coerente con il profilo del caso economico toscano, che la Parte E costruisce esattamente su questa base.

D.3 I benchmark internazionali

L'evidenza sperimentale è corroborata dall'esperienza dei grandi programmi internazionali, che offrono modelli organizzativi maturi e dati su larga scala. Il programma inglese costituisce il riferimento principale per l'organizzazione del servizio. Il modello olandese mostra un'integrazione capillare nello studio del medico di base. L'iniziativa australiana documenta l'ampliamento della popolazione in trattamento. Il modello statunitense è validato da una mole imponente di studi controllati. Le esperienze italiane, infine, pur derivando in parte da campioni limitati, anticipano l'integrazione nelle cure primarie, oggi corroborata dalla sperimentazione toscana fondata su una legge dedicata. La tabella seguente li riepiloga.

Programma	Assetto	Esiti clinici e organizzativi
Programma inglese (NHS Talking Therapies)	Integrato; intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio > 98%; > 1,3 mln/anno
Modello olandese (POH-GGZ)	Integrato nelle cure primarie	Adozione ~3/4 dei medici; ruolo complementare
Iniziativa australiana (Better Access)	Invio esterno	Trattamento dal 35% al 46%; elevata soddisfazione
Collaborative Care (Stati Uniti)	Équipe integrata	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione; -41% ricoveri
Sperimentazione regionale toscana	Integrata nelle cure primarie; istituita per legge e attiva	~ 2.300 cittadini in diciotto mesi; valutazione positiva

Tabella D.2. *I benchmark internazionali e l'esperienza toscana sul piano clinico e organizzativo (il confronto economico è nella Parte E).*

D.4 La trasferibilità al contesto regionale

La trasposizione di questi risultati al contesto regionale richiede cautela metodologica: i programmi internazionali provengono da sistemi diversi per organizzazione, finanziamento e cultura, e le loro stime — di efficacia e, ancor più, economiche — non vanno trasferite meccanicamente, ma validate localmente. Per la Toscana, tuttavia, la trasferibilità è facilitata da una circostanza peculiare: la regione non deve trasferire soltanto

stime estere, poiché dispone già di una base di evidenza locale costituita dalla propria sperimentazione, fondata sulla legge 39 del 2022, attiva dal settembre 2024 e progressivamente estesa, che nei primi diciotto mesi ha intercettato circa 2.300 cittadini con valutazione positiva. Il vantaggio peculiare della Toscana è dunque di poter validare il modello sui propri dati operativi; a ciò si aggiungono l'infrastruttura informatica regionale, la rete delle Case della Comunità e delle Case della Salute e la struttura amministrativa consolidata in sole tre Aziende USL, che costituiscono un terreno favorevole alla valutazione rigorosa di un modello già in esercizio. Una precisazione conclusiva si impone sul piano della correttezza: i rapporti beneficio-costo spesso citati nel dibattito pubblico sono semplificazioni divulgative; le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno in intervalli più prudenti, ed è a questi che lo studio si attiene. Stabilita l'efficacia e graduata l'evidenza, la parte che segue ne traduce i risultati nella valutazione economica.

STUDIO REGIONALE · REGIONE TOSCANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte E

La valutazione economica

Costi, esiti, costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale e casi economico e finanziario

Quinto dominio dell'HTA · il valore economico

Parte E — La valutazione economica

Stabilita l'efficacia nella Parte D, questa quinta parte ne traduce i risultati in termini economici, secondo il quinto dominio della valutazione e nel rigore di reporting dello standard CHEERS. È la parte centrale per il decisore di finanza pubblica, e ne riassume l'esito già in apertura: il caso finanziario, riferito al solo bilancio sanitario, presenta un saldo lievemente negativo, mentre il caso economico, riferito alla collettività, è ampiamente positivo. La parte identifica e misura i costi (capitolo E.1) e gli esiti (E.2); ne deriva il costo-efficacia e il costo-utilità (E.3); analizza l'impatto sul bilancio (E.4); stima il ritorno sociale (E.5); e ricompone il caso economico e il caso finanziario (E.6). I valori sono espressi in tre scenari di copertura, e l'intera analisi tiene rigorosamente distinto ciò che lo Stato risparmia da ciò che la collettività guadagna.

E.1 L'identificazione e la misura dei costi

Il costo del servizio comprende le remunerazioni dei professionisti, i costi organizzativi e di coordinamento e la quota destinata alla formazione congiunta, ed è stimato per scenario di copertura ed espresso a regime. A regime, esso è dell'ordine di 22 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 33 nello scenario base e 44 nello scenario espansivo. La stima muove da un valore unitario per incarico dell'ordine di 55.000 euro annui, regionalizzato in proporzione alla popolazione e al numero di professionisti; la sperimentazione è peraltro già finanziata, ma su base libero-professionale e per un importo che copre una frazione ridotta del fabbisogno. La tabella seguente espone il costo per scenario; la condizione attuale, in cui il servizio è attivo in via sperimentale ma sottodimensionato, comporta una spesa dedicata dell'ordine di 0,7 milioni di euro annui.

Scenario	Psicologi	Costo annuo (mln €)
Attuale (sperimentazione, sottodimensionata)	~ 5% del fabbisogno	~ 0,7
Conservativo	~ 400	~ 22
Base	~ 600	~ 33
Espansivo	~ 790	~ 44

Tabella E.1. Il costo del servizio per scenario di copertura. Il servizio è oggi attivo in via sperimentale, ma dimensionato a circa il 5% del fabbisogno.

E.2 L'identificazione e la misura degli esiti

Gli esiti di salute sono espressi in anni di vita ponderati per la qualità e in esiti clinici validati; i tassi di recupero e di miglioramento sono desunti dai benchmark consolidati e applicati in via prudenziale. Le misure impiegate, nei soli punteggi complessivi, sono il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia, con un tasso di recupero di riferimento dell'ordine del 50%, coerente con i dati reali del programma inglese e con i primi dati della sperimentazione regionale.

E.3 Il costo-efficacia e il costo-utilità

Il costo per anno di vita ponderato per la qualità si colloca al di sotto della soglia comunemente adottata; l'analisi per paziente, sviluppata in dettaglio nella Parte F, indica anzi condizioni di dominanza dell'intervento rispetto all'opzione di non intervento, ossia un esito al tempo stesso migliore e meno costoso sul ciclo di vita del disturbo. La soglia di riferimento adottata è dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, in linea con la prassi internazionale.

E.4 L'impatto sul bilancio

L'analisi di impatto sul bilancio misura i risparmi diretti per il Servizio sanitario regionale, articolati nei canali del pronto soccorso, della farmaceutica e dei ricoveri e prestazioni specialistiche evitabili; per la Toscana il canale della mobilità recuperata è inapplicabile come leva di risparmio, poiché la regione è nettamente creditrice. I risparmi diretti complessivi sono stimati nell'ordine di 14, 22 e 34 milioni di euro annui nei tre scenari, collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa dell'intervallo. Il saldo diretto, differenza tra risparmi diretti e costo del servizio, è dell'ordine di -8, -11 e -10 milioni di euro annui: lievemente negativo, coerentemente con la condizione di regione creditrice, per la quale il canale della mobilità non concorre al pareggio. Questo saldo negativo è dichiarato senza attenuazioni e non rappresenta una debolezza dell'analisi, ma il suo profilo onesto: a differenza della Puglia, dove il recupero della mobilità passiva concorre al pareggio diretto, in Toscana il valore dell'intervento risiede in misura preponderante nelle ricadute sociali, pur conservando, nel contesto delle liste di attesa, una salienza diretta non trascurabile. La tabella seguente dettaglia i canali e il saldo.

Canale (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Pronto soccorso	3	4	5
Farmaceutica	3	4	6
Ricoveri e specialistica	8	14	23
Mobilità recuperata (inapplicabile)	0	0	0
Risparmi diretti (totale)	~ 14	~ 22	~ 34
Costo del servizio	~ 22	~ 33	~ 44
Saldo diretto (solo SSR)	~ -8	~ -11	~ -10

Tabella E.2. I risparmi diretti per canale e il saldo diretto sul bilancio sanitario, per scenario. Il canale della mobilità è nullo (regione creditrice) e il saldo diretto è lievemente negativo.

E.5 Il ritorno sociale

Il valore dell'intervento, in Toscana, si manifesta soprattutto al di fuori del bilancio sanitario. Le ricadute economico-sociali comprendono la maggiore produttività recuperata, la riduzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, le efficienze nel sistema dei servizi di salute mentale e il sollievo alle figure di cura familiari; in una delle regioni più anziane d'Italia, a forte presenza di cronicità, la produttività recuperata e il sollievo ai familiari sono le voci di maggior peso. Stimate secondo i metodi del ritorno sociale sull'investimento e con criteri conservativi, queste ricadute sono dell'ordine di 71 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 133 nello scenario base e 207 nello scenario espansivo.

E.6 Il caso economico e il caso finanziario

La ricomposizione delle grandezze restituisce il quadro complessivo. Il ritorno complessivo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali, è dell'ordine di 85, 155 e 241 milioni di euro annui nei tre scenari; al netto del costo del servizio, il saldo complessivo è dell'ordine di +63, +122 e +197 milioni di euro annui. Il rapporto beneficio-costi complessivo è conseguentemente dell'ordine di 3,9:1 nello scenario conservativo, 4,7:1 nel base e 5,5:1 nell'espansivo, in linea con il valore validato sulle altre regioni. La lettura corretta del risultato passa per la distinzione, propria del Five Case Model, tra il caso finanziario — riferito al solo bilancio sanitario e lievemente negativo — e il caso economico — riferito alla collettività e ampiamente positivo. Sul piano della sostenibilità, il costo del servizio si colloca nell'ordine dello 0,3-0,5% di un Fondo Sanitario Regionale dell'ordine di 8 miliardi di euro; benché la regione operi sotto pressione finanziaria, l'importo è contenuto e una quota è già a bilancio per la sperimentazione attiva. Resta la lacuna prioritaria, già dichiarata: le grandezze economiche sono in parte ricostruite per quota di popolazione e non estratte dai conti regionali certificati, la cui verifica è condizione per la presentazione alle autorità di finanza pubblica, ed è in Toscana agevolata dai dati della sperimentazione. La tabella seguente sintetizza il caso economico e il caso finanziario.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Risparmi diretti (SSR)	~ 14	~ 22	~ 34
Ricadute economico-sociali	~ 71	~ 133	~ 207
Ritorno complessivo	~ 85	~ 155	~ 241
Costo del servizio	~ 22	~ 33	~ 44
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -8	~ -11	~ -10
Saldo complessivo (caso economico)	+63	+122	+197
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella E.3. Sintesi economica per scenario: il caso finanziario (saldo diretto negativo) e il caso economico (saldo complessivo positivo).

STUDIO REGIONALE · REGIONE TOSCANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte F

Modellazione decisionale e incertezza

Struttura del modello, parametri, sensibilità deterministica e probabilistica, valore dell'informazione

Quinto dominio dell'HTA · la modellazione e l'incertezza

Parte F — Modellazione decisionale e incertezza

Questa parte completa il quinto dominio sviluppando la modellazione decisionale che sorregge le stime economiche della Parte E e la gestione esplicita dell'incertezza. Il modello e i suoi risultati per paziente sono di natura clinica ed economica generale e sono pertanto indipendenti dalla regione: ciò che muta sono i soli riferimenti al contesto e alle fonti di calibrazione regionale. La parte descrive la struttura del modello (capitolo F.1); ne specifica i parametri e la calibrazione (F.2); ne saggia la robustezza con la sensibilità deterministica (F.3) e con quella probabilistica (F.4); e ne trae le priorità di acquisizione dei dati con il valore dell'informazione (F.5). Il risultato per paziente — una dominanza dell'intervento — è il fondamento microeconomico su cui poggiano le stime aggregate, e ne spiega la coerenza con il saldo diretto regionale.

F.1 La struttura del modello

La modellazione segue le buone pratiche di ricerca riconosciute ed è riportata secondo lo standard CHEERS. [1244][1245][1246] Lo strumento adottato è un modello di Markov a coorte, che rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi — sintomatico, recupero, cronico, morte — scanditi da cicli con correzione di metà ciclo. [1247] Nel caso base, riferito a un singolo paziente su orizzonte quinquennale e a valori scontati, il braccio dell'intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un'utilità di 3,627 anni di vita ponderati, contro 3.799 euro e 3,392 dell'assistenza usuale: l'intervento è al tempo stesso meno costoso e più efficace, configurando una dominanza.

[1248] La dominanza non è un artificio, ma la conseguenza della struttura del modello: l'intervento accresce il tempo nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce il tempo nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte. [1249] La tabella seguente riporta i risultati del caso base.

Caso base, per paziente	Intervento	Cura usuale	Differenza
Costo sanitario (5 anni, scontato)	~ 2.495 €	~ 3.799 €	- 1.304 €
Utilità (anni di vita ponderati)	3,627	3,392	+ 0,236
Esito	—	—	Dominanza (più efficace, meno costoso)

Tabella F.1. Risultati del caso base del modello di Markov, per paziente, su orizzonte quinquennale scontato.

F.2 I parametri e la calibrazione

I parametri di costo del modello, per ciclo, sono dell'ordine di 40 euro per lo stato di recupero, 700 euro per lo stato cronico e 300 euro per l'intervento psicologico una tantum; è questa struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. [1250] Alle grandezze sono assegnate distribuzioni di probabilità per l'analisi probabilistica: Beta per le probabilità di transizione e per le utilità, vincolate tra zero e uno, e Gamma per i costi, vincolati ai valori positivi; i valori centrali sono tratti dall'evidenza internazionale e, per i parametri regionali, sono da calibrare sui valori toscani certificati e sui dati di esito della sperimentazione già attiva non appena consolidati. [1251] La tabella seguente riepiloga i principali parametri e le distribuzioni assegnate.

Parametro	Valore	Distribuzione
Costo per ciclo — stato di recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — stato cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento psicologico (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione tra gli stati	da fonti, per braccio	Beta
Utilità associate agli stati	da fonti	Beta

Tabella F.2. Principali parametri del modello e distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

F.3 La sensibilità deterministica

La robustezza del risultato è saggiata, in prima istanza, con un'analisi di sensibilità a una via, nella quale ciascun parametro è fatto variare del 25% in più e in meno, misurandone l'effetto sul beneficio monetario netto; il diagramma a tornado ordina i parametri per influenza, individuando nell'efficacia clinica, nei tassi di ricaduta e di cronicizzazione e nel costo dello stato cronico i fattori più determinanti. [1252] Oltre all'incertezza dei parametri, l'incertezza sulla struttura e sulle assunzioni del modello è trattata mediante analisi di scenario, con validazione della coerenza interna ed esterna secondo lo standard di reporting adottato. [1253]

F.4 La sensibilità probabilistica e la curva di accettabilità

L’analisi di sensibilità probabilistica esegue il modello diecimila volte, estraendo a ogni iterazione i parametri dalle rispettive distribuzioni, così da propagare l’incertezza dei parametri sull’incertezza del risultato.^[1254] Adottando la soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità,^[1255] la curva di accettabilità indica una probabilità dell’88,9% che l’intervento sia costo-efficace e dell’84,6% che sia addirittura dominante, con un beneficio monetario netto medio di circa 7.815 euro per paziente e un intervallo di credibilità al 95% compreso fra circa -5.736 e circa +21.501 euro.^[1256] È qui necessario chiarire la coerenza, solo apparentemente paradossale, tra questo risultato e il saldo diretto regionale: la probabilità di costo-efficacia è una misura di efficienza per paziente, che valorizza il guadagno di salute e l’intera traiettoria di costo, mentre il saldo diretto aggregato della Parte E, lievemente negativo per la Toscana, incorpora le correzioni per peso morto e per l’effettiva monetizzabilità nel bilancio dei costi evitati e sconta l’inapplicabilità del canale della mobilità. L’efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è lievemente negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali.^[1257] La tabella seguente sintetizza i risultati.

Misura dell’analisi probabilistica	Risultato
Iterazioni della simulazione Monte Carlo	10.000
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 €/QALY)	88,9%
Probabilità di dominanza	84,6%
Beneficio monetario netto medio	~ 7.815 € per paziente
Intervallo di credibilità al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 €

Tabella F.3. Risultati dell’analisi di sensibilità probabilistica (per paziente, soglia 30.000 €/QALY).

F.5 Il valore dell’informazione

L’analisi del valore dell’informazione chiude il dominio traducendo l’incertezza residua in priorità di ricerca: il valore atteso dell’informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l’incertezza, e il valore atteso dell’informazione perfetta sui parametri indica quali grandezze sia prioritario misurare con precisione.^[1258] Per la Toscana, i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso — sono quelli su cui il valore dell’informazione è più elevato, e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati alle aziende; un vantaggio peculiare è che la regione dispone già dei propri dati di esito della sperimentazione attiva, da consolidare come fonte primaria di calibrazione.^[1259] La via maestra per ridurre l’incertezza, infine, non è soltanto analitica ma empirica: poiché il servizio è già attivo in via sperimentale e si è esteso in modo scaglionato tra le strutture, la riduzione dell’incertezza poggia sul confronto prima-dopo l’attivazione del 2024 e sulla progressione per cunei tra le sedi, oggetto della Parte L, che consente di sostituire progressivamente le stime con misure osservate sui dati regionali.^[1260] Completato così il nucleo della valutazione — efficacia, economia, modellazione — le parti successive ne affrontano le dimensioni distributive, etiche, organizzative e valutative, a partire dall’equità.

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte G

Equità e impatto distributivo

Analisi di equità, costo-efficacia distributiva, divari territoriali e impoverimento

Ottavo dominio dell’HTA · il profilo del paziente e sociale

Parte G — Equità e impatto distributivo

Misurato il valore economico nelle Parti E ed F, questa settima parte ne esamina la distribuzione, secondo l’ottavo dominio della valutazione. La domanda non è soltanto se l’intervento generi valore, ma a chi quel valore arrivi: un intervento può essere efficiente e tuttavia accrescere le disuguaglianze, oppure, come in questo caso, migliorare l’esito medio e ridurle insieme. La parte definisce le dimensioni dell’equità e le variabili seguite (capitolo G.1); applica gli strumenti della costo-efficacia distributiva (G.2); e analizza i divari territoriali e l’impoverimento (G.3). Per la Toscana, l’equità si gioca su assi peculiari — la dualità fra l’area metropolitana centrale e le aree interne e montane, l’invecchiamento e la dimensione multiculturale — e sull’esigenza di estendere uniformemente, dalla sperimentazione a tutte le Case della Comunità delle tre Aziende USL, un servizio già attivo ma circoscritto.

G.1 L’analisi di equità

L’equità è trattata come dimensione costitutiva della valutazione, e non come considerazione accessoria.^[1261]
^[1262]^[1263]^[1264]^[1265]^[1266]^[1267]^[1268]^[1269]^[1270]^[1271]^[1272]^[1273]^[1274] La salute mentale presenta ovunque un gradiente sociale, ma in Toscana, dove il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato, il gradiente socio-economico non è il tratto distintivo: prevalgono tre dimensioni diverse, la dualità fra l’area metropolitana centrale e le aree interne e montane, l’invecchiamento della popolazione e una rilevante dimensione multiculturale.^[1275] La gratuità, la prossimità e l’assenza di stigma del servizio di primo livello abbattano le barriere che gravano sulle popolazioni svantaggiate, e in Toscana rilevano in particolare l’abbattimento della barriera geografica nelle aree interne e montane, dove la distanza dai servizi è il principale ostacolo, e quello della barriera culturale e linguistica per l’utenza straniera.^[1276] La tabella seguente espone le dimensioni dell’equità e le variabili che lo studio segue.^[1277]

Dimensione di equità	Variabili seguite dallo studio
Accesso	Tempi di attesa; accessibilità geografica nelle aree interne e montane; accessibilità culturale e linguistica; contrasto alle liste di attesa
Protezione finanziaria	Riduzione della spesa privata diretta; dell’impoverimento connesso alle cure; delle spese catastrofiche
Gruppi vulnerabili	Equità di genere; età anziana e gruppi fragili; popolazione straniera (11,8%); persone con disabilità; gratuità
Territorio	Riduzione del divario area metropolitana-aree interne e montane; uniformità del servizio fra le ASL; copertura del bisogno non soddisfatto

Tabella G.1. Le dimensioni dell’equità e le variabili seguite dallo studio.

G.2 La costo-efficacia distributiva

La dimensione distributiva è misurata con gli strumenti della costo-efficacia distributiva, che estendono la valutazione economica all'equità stimando come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l'effetto sulle disuguaglianze.^[1278] La direzione del risultato è favorevole: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove l'accesso è oggi più difficile — le aree interne e montane, l'età anziana, l'utenza straniera e i gruppi gravati dalle liste di attesa — i benefici si concentrano sui più svantaggiati, riducendo il gradiente territoriale e migliorando al tempo stesso l'esito medio.^[1279] L'attribuzione di pesi maggiori ai benefici dei più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, in via conservativa, il rapporto non ponderato già esposto, tanto più prudente in una regione non prevalentemente deprivata.^[1280] Il meccanismo operativo dell'equità è un algoritmo allocativo che distribuisce gli incarichi non secondo la sola popolazione, ma ponderando ciascuna zona-distretto per l'invecchiamento, la deprivazione, la cronicità e la presenza straniera, con l'indice di vecchiaia quale fattore di maggior peso nel contesto toscano, affiancato dalla presenza straniera nell'area centrale.^[1281] A tal fine si impiega un indice di deprivazione multipla che sintetizza reddito, occupazione, istruzione, salute, condizione abitativa e ambiente.^[1282] La tabella seguente riepiloga gli strumenti.

Strumento della costo-efficacia distributiva	Che cosa misura
Anni di vita ponderati per l'equità	Guadagni di salute con pesi per lo svantaggio
Indice di concentrazione	Relazione tra esito di salute e posizione socio-economica
Indici di disuguaglianza (assoluta e relativa)	Gradiente dell'esito lungo lo stato socio-economico
Valutazione d'*****impatto sull*****equità	Distribuzione degli effetti per gruppi vulnerabili e per area
Indice di deprivazione multipla	Reddito, occupazione, istruzione, salute, abitare, ambiente

Tabella G.2. Gli strumenti della costo-efficacia distributiva e dell'analisi di equità.

G.3 I divari territoriali e l'impoverimento

Il divario territoriale rilevante, in Toscana, non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra l'area metropolitana centrale, lungo l'asse Firenze-Prato-Pisa, densa e ben servita, e le aree interne e montane, a popolazione anziana e dispersa e soggette a spopolamento, dove la sola presenza fisica di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio, integrato dalla telepsicologia.^[1283] Poiché il canale della mobilità recuperata è inapplicabile perché la regione è creditrice, le principali leve distributive diventano la riduzione delle liste di attesa, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato, l'estensione uniforme del servizio dalla sperimentazione a tutte le Case della Comunità delle tre Aziende USL, e l'accesso nelle aree interne e montane.^[1284] A queste si aggiunge la protezione finanziaria: il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata per la psicoterapia e l'impoverimento connesso alle cure, con beneficio maggiore per i redditi bassi.^[1285] La forma più elementare di equità, infine, è la copertura del bisogno non soddisfatto, dell'ordine di 730.000 persone in larga parte non intercettate, ossia il raggiungere proprio coloro che meno accedrebbero spontaneamente ai servizi.^[1286] Tutti questi profili sono tradotti in indicatori e affidati al sistema di monitoraggio della Parte L, che ne accerta nel tempo il conseguimento.^[1287] Definita la dimensione distributiva, la parte che segue affronta i profili etico, giuridico e organizzativo.

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Profilo etico, profili giuridici e costituzionali, profilo organizzativo e conformità

Domini sei, sette e nove dell'HTA · etica, organizzazione e diritto

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte completa la valutazione affrontando i tre domini che restano oltre quelli già trattati: il profilo etico, il profilo giuridico e costituzionale e il profilo organizzativo e di conformità. Sono i piani che ne saggiamente la legittimità e l'ammissibilità — non basta che un intervento sia efficace ed efficiente, occorre che sia eticamente fondato, giuridicamente legittimo e organizzativamente conforme. La parte esamina il profilo etico (capitolo H.1); i profili giuridici e costituzionali, con specifico riguardo alla competenza regionale (H.2); e il profilo organizzativo e la conformità, segnatamente degli strumenti di intelligenza artificiale (H.3). Per la Toscana, il punto giuridico saliente è che il servizio è già istituito da una legge regionale dedicata ed è operante in via sperimentale: la decisione verte sul portarlo a regime e sul dimensionarlo, non sul prevederlo né sul legiferarlo.

H.1 Il profilo etico

Il profilo etico dell'intervento è solido.^{[1288][1289][1290][1291][1292][1293][1294][1295][1296][1297][1298][1299][1300][1301][1302][1303]} Le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, già trattata, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato, con la persona sempre soggetto e mai oggetto della presa in carico.^[1304] Il consenso è modulare e reso anche in forma digitale, e nella salute mentale, dove i dati sono ultrasensibili, la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi vi acceda.^[1305] Sul piano della condotta della ricerca, gli esiti sono resi pubblici a prescindere dal loro segno, a garanzia contro la selezione dei risultati favorevoli, e l'impianto è sottoposto al comitato etico competente.^[1306] Una cautela specifica presidia i minori e le persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e dell'emergenza in raccordo con il medico curante.^[1307]

H.2 I profili giuridici e costituzionali

Sul piano giuridico, l'intervento si fonda anzitutto sull'articolo 32 della Costituzione e sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che configurano la salute come diritto fondamentale e il servizio come universale, eguale ed equo.^[1308] Il riparto di competenze è il punto dirimente: la tutela della salute è materia concorrente, nella quale alle Regioni spetta l'organizzazione del servizio, e la Toscana ha esercitato tale competenza nella forma più piena, approvando una legge regionale dedicata anziché limitarsi a un atto amministrativo.^[1309] La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni resta invece competenza esclusiva dello Stato, ed è la leva di un'eventuale uniformazione nazionale.^[1310] Di rilievo diretto è la sentenza della Corte costituzionale del 2021, che ha riconosciuto legittimo il modello regionale di psicologia di base in quanto organizzazione che si avvale di professionisti già esistenti: un precedente che conforta in modo specifico la Toscana, che quel modello ha consolidato in una legge.^[1311] La base regionale di tale scelta è costituita dalla legge 39 del 2022 e dal suo regolamento di attuazione, accompagnati dalle deliberazioni che hanno avviato ed esteso la sperimentazione; il coordinamento, in assenza di un'azienda regionale unica, è affidato alla Regione, alle tre Aziende USL e

all’organismo di governo clinico.^[1312] Quanto ai vincoli di finanza pubblica, il principio di destinazione dei fondi sanitari ai livelli essenziali è rispettato dalla riforma; la Toscana non è in piano di rientro ed è regione creditrice, pur operando sotto pressione finanziaria.^[1313] La tabella seguente riepiloga i riferimenti.

Riferimento giuridico	Contenuto rilevante
Articolo 32 Cost. e legge n. 833/1978	Salute come diritto; Servizio sanitario universale, eguale ed equo
Articolo 117, terzo comma, Cost.	Tutela della salute: competenza concorrente (principi allo Stato, organizzazione alle Regioni)
Articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.	Livelli essenziali delle prestazioni: competenza esclusiva statale
Legge regionale n. 39/2022 e regolamento (DGR 43/2024)	Base regionale: il servizio è istituito da una legge dedicata e attuato con regolamento (tratto distintivo della Toscana)
Corte costituzionale, sentenza n. 241/2021	Modello regionale di psicologia di base riconosciuto legittimo (precedente che conforta la scelta legislativa)
Sperimentazione (DGR 1601/2023, 244/2025 e proroga 2026)	Servizio operante in via sperimentale; decisione: strutturazione a regime e dimensionamento

Tabella H.1. I riferimenti giuridici e costituzionali essenziali dell’intervento.

H.3 Il profilo organizzativo e la conformità

Sul piano organizzativo, il servizio opera nel rispetto delle norme deontologiche della professione, sotto la vigilanza dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, che ha accompagnato l’attivazione del servizio e concorre alla governance e alla formazione.^[1314] L’impiego dell’intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali: il medico resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell’intervento psicologico, e l’intelligenza artificiale è assimilata a un dispositivo di supporto e non a una figura che compie atti, sicché non si introduce una nuova professione, ma uno strumento che assiste quelle esistenti.^[1315] La conformità degli strumenti è governata dal quadro europeo — il regolamento sull’intelligenza artificiale, quello sui dispositivi medici e quello sulla protezione dei dati — cui si aggiungono la supervisione umana costante, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias e la trasparenza.^[1316] Una particolare attenzione è dedicata all’equità digitale, perché gli strumenti non generino nuove disuguaglianze: sono previsti canali tradizionali per le persone anziane delle aree interne e montane e il supporto multilingue per la popolazione straniera, sempre con l’alternativa in presenza garantita.^[1317] La protezione dei dati, infine, è assicurata da misure robuste di sicurezza, dal consenso modulare e dalla collaborazione con l’Autorità garante.^[1318] La tabella seguente riepiloga il quadro della conformità e della governance. Definiti i profili etico, giuridico e organizzativo, la parte che segue affronta l’attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

Ambito	Riferimento	Garanzia
Deontologia	Ordine degli Psicologi della Toscana	Rispetto delle norme deontologiche; concorso alla governance
Responsabilità clinica	Medico e psicologo	Ruoli invariati; l'IA è strumento di supporto
IA e dispositivi	AI Act, dispositivi medici, protezione dei dati	Marcatura CE; supervisione umana; validazione periodica
Governance dell'IA	Comitato etico-scientifico; OTGC	Monitoraggio dei bias; trasparenza; non discriminazione
Equità digitale	Canali paralleli; supporto multilingue	Alternativa in presenza sempre garantita
Protezione dei dati	Crittografia; pseudonimizzazione	Consenso modulare; collaborazione con il Garante

Tabella H.2. Il quadro della conformità organizzativa e di governance dell'intervento.

STUDIO REGIONALE · REGIONE TOSCANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Scienza dell'implementazione, dimensionamento, casi commerciale e gestionale, sostenibilità finanziaria

Settimo dominio dell'HTA · il profilo organizzativo

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Le parti precedenti hanno mostrato che l'intervento è efficace, efficiente, equo e legittimo; questa parte affronta la domanda decisiva per il decisore: è attuabile e sostenibile. La fattibilità è trattata con gli strumenti della scienza dell'implementazione, e la sostenibilità con i casi commerciale, gestionale e finanziario del modello di valutazione degli investimenti pubblici. La parte presenta i quadri della scienza dell'implementazione (capitolo I.1); disegna il dimensionamento del servizio (I.2); definisce il caso commerciale, ossia il modello contrattuale e la tariffa (I.3); il caso gestionale, ossia la governance e i rischi (I.4); e il caso finanziario, ossia la sostenibilità e le coperture (I.5). Per la Toscana, la circostanza che il servizio sia già istituito per legge e attivo in via sperimentale rende l'attuazione non un avvio ex novo, ma una strutturazione a regime e un progressivo dimensionamento di un servizio esistente.

I.1 La scienza dell'implementazione

L'attuazione è trattata con il rigore della scienza dell'implementazione, e non lasciata all'improvvisazione.^[1319]
^{[1320][1321][1322][1323][1324][1325][1326][1327][1328][1329][1330][1331][1332][1333][1334]} Due quadri complementari ne governano l'analisi. Il modello RE-AIM misura la riuscita e la validità esterna dell'attuazione lungo cinque dimensioni — portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento — e per la Toscana la dimensione del mantenimento è dirimente, trattandosi di consolidare a regime un servizio già avviato.^[1335] Il quadro consolidato per la ricerca sull'implementazione ne spiega invece i determinanti, articolati in cinque domini,

consentendo di individuare in anticipo barriere e facilitatori.^[1336] Da questi quadri lo studio deriva i determinanti che seguirà: il tasso di copertura, l’adozione delle sedi, la fedeltà al modello, i tempi di dimensionamento, il numero di psicologi reclutati e formati e il grado di integrazione nei flussi di lavoro.^[1337] La tabella seguente riepiloga i due quadri.

Dimensione	Che cosa misura o spiega
Portata (RE-AIM)	Quota della popolazione bersaglio raggiunta
Efficacia (RE-AIM)	Esiti clinici e di sistema effettivamente conseguiti
Adozione (RE-AIM)	Adesione delle sedi e dei professionisti
Implementazione (RE-AIM)	Fedeltà al modello e qualità dell’attuazione
Mantenimento (RE-AIM)	Sostenibilità del servizio nel tempo (dirimente in Toscana)
Determinanti (quadro CFIR)	Innovazione, contesto esterno e interno, individui, processo

Tabella I.1. I quadri della scienza dell’implementazione: RE-AIM per gli esiti, CFIR per i determinanti.

I.2 Il disegno del dimensionamento

Il servizio, già attivo in via sperimentale in ventuno strutture delle tre Aziende USL, non è dispiegato da zero ma dimensionato progressivamente: la copertura, oggi dell’ordine del 5% del fabbisogno, è estesa per fasi semestrali a tutte le Case della Comunità verso il regime, a partire dalle zone di maggiore prontezza, secondo un ordine definito dalla Giunta su criteri trasparenti e con il coordinamento unitario della Regione.^[1338] Questo disegno assolve una doppia funzione: organizzativa, perché consente un incremento graduale compatibile con i tempi del reclutamento e della formazione; e valutativa, perché, insieme al confronto prima-dopo l’attivazione del settembre 2024, la progressione per cunei tra le strutture fonda la valutazione controfattuale d’impatto della Parte L.^[1339] Il reclutamento, a fronte di un fabbisogno di circa 790 psicologi, avviene tramite elenco aziendale e rapporto convenzionale, valorizzando in prima applicazione i professionisti già operanti nella sperimentazione, oggi con incarichi libero-professionali.^[1340] Il cronoprogramma procede per fasi semestrali, con il monitoraggio che accompagna l’intero arco e prosegue oltre il raggiungimento del regime.^[1341] Tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% in fase di dimensionamento, che il monitoraggio è chiamato a verificare sui dati regionali già disponibili.^[1342] La tabella seguente espone le fasi.

Fase del dimensionamento	Contenuto
Fase 1 (primo semestre)	Strutturazione a regime nelle strutture già attive e conversione degli incarichi libero-professionali in rapporto convenzionale; dimensionamento iniziale nelle zone di maggiore prontezza
Fasi successive (semestri)	Estensione progressiva da ventuno strutture a tutte le Case della Comunità delle tre Aziende USL verso il fabbisogno
Fase finale (regime)	Copertura piena del fabbisogno regionale (~790 psicologi)
Attività trasversale	Monitoraggio e valutazione, che proseguono oltre il raggiungimento del regime

Tabella I.2. Le fasi del dimensionamento del servizio, dalla sperimentazione in ventuno strutture alla copertura a regime nelle tre Aziende USL.

I.3 Il caso commerciale: il modello contrattuale e la tariffa

Il caso commerciale riguarda la fattibilità dell’assetto contrattuale. Esso poggia su un rapporto convenzionale ancorato all’accordo della specialistica ambulatoriale, da cui discende un costo medio per incarico dell’ordine di 55.000 euro l’anno e i tre scenari di spesa — 22, 33 e 44 milioni — già esposti nella Parte E. Il nodo specifico della Toscana è il passaggio dagli attuali incarichi libero-professionali della sperimentazione, precari, a un rapporto convenzionale stabile, analogo a quello dei medici di medicina generale; il modello non richiede la creazione di nuove figure e può muovere dalla base già operante.^[1343]

I.4 Il caso gestionale: la governance e i rischi

Il caso gestionale riguarda la governance e i rischi. L’attuazione è governata su due livelli: a livello regionale, un comitato di indirizzo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, le tre Aziende USL, le quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, l’Organismo Toscano di Governo Clinico, l’ente regionale di supporto tecnico-amministrativo, l’Ordine degli Psicologi della Toscana, la medicina generale, la pediatria di libera scelta e le università di Firenze, Pisa e Siena; a livello aziendale, ciascuna Azienda USL è responsabile dell’attuazione nel proprio ambito, secondo l’indirizzo unitario della Regione.

^[1344] Il rischio più specifico della Toscana è la precarietà della fase sperimentale, affidata a incarichi dipendenti da rifinanziamenti periodici; ad esso si aggiungono il reclutamento insufficiente, la debole adesione della medicina generale e l’interoperabilità incompleta. Poiché la legge è già vigente, la principale misura di mitigazione è la strutturazione a regime con rapporto convenzionale stabile, e il dimensionamento graduale consente di osservare e correggere.^[1345] La tabella seguente riepiloga rischi e misure.

Rischio	Natura	Misura di mitigazione
Precarietà della sperimentazione	Base libero-professionale dipendente da rifinanziamenti periodici	Strutturazione a regime; rapporto convenzionale stabile (legge già vigente)
Reclutamento insufficiente	Carenza di psicologi formati	Dimensionamento graduale; formazione anticipata
Adesione della medicina generale	Integrazione debole nel percorso	Protocolli di invio; formazione congiunta; governance condivisa
Sistemi informativi	Interoperabilità incompleta	Cartella interoperabile; standard nazionali; infrastruttura regionale
Uniformità tra le ASL	Estensione disomogenea oltre le strutture sperimentali	Algoritmo allocativo; indirizzo regionale; struttura consolidata a tre ASL

Tabella I.3. I rischi attuativi e le relative misure di mitigazione.

I.5 La sostenibilità finanziaria e le coperture

Il caso finanziario riguarda le coperture e la sostenibilità. Le fonti comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, dell'ordine di 8 miliardi di euro, di cui una quota è già destinata alla sperimentazione attiva, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'infrastruttura territoriale e digitale, e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali.^[1346] Il vincolo di bilancio richiede prudenza: la Toscana opera sotto pressione finanziaria, pur non essendo in piano di rientro ed essendo regione creditrice, ma il costo del servizio, anche a massima copertura, costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale del finanziamento, ed essendone già a bilancio una quota, l'investimento incrementale è quello necessario a colmare il divario verso il fabbisogno.^[1347] Nel lungo periodo, la leva decisiva della sostenibilità non è l'istituzionalizzazione per legge, già acquisita, ma la strutturazione a regime con un rapporto convenzionale stabile, che sottrarrebbe il servizio alla precarietà dei rifinanziamenti periodici, cui si aggiungono la modestia del costo, il forte ritorno sociale e le economie di scala della struttura consolidata.^[1348] Resta ferma la cautela metodologica già dichiarata: i risultati italiani provengono in parte da letteratura grigia e i benchmark esteri richiedono adattamento, sicché la verifica empirica sui dati regionali, prevista dalla Parte L, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate.^[1349]

Nota di aggiornamento (marzo 2026). A conferma della traiettoria di attuazione qui descritta, la sperimentazione toscana — avviata nel settembre 2024 in sette sedi ai sensi della legge regionale n. 39/2022 e del regolamento attuativo di cui alla delibera n. 43/2024 — è stata estesa dalla Giunta regionale, con delibera n. 244 del 3 marzo 2025, a ulteriori dieci sedi delle tre Aziende Sanitarie, raggiungendo un totale di ventuno strutture coinvolte; la valutazione dell'andamento, giudicata positiva dalla Regione, ha condotto a una proroga di ulteriori dodici mesi dell'intera sperimentazione a partire da marzo 2026, con uno stanziamento regionale dedicato di 675.000 euro per il nuovo periodo di attività ([Giovanisi, Regione Toscana, 9 marzo 2026](#); [Toscana Medica, settembre 2025](#)). Questo sviluppo corrobora, sul piano empirico, sia la dimensione “Mantenimento” del quadro RE-AIM richiamata al capitolo I.1, sia la valutazione di sostenibilità della presente Parte I, senza tuttavia modificare i valori di rendimento economico qui adottati, ancorati in via esclusiva al duplice intervallo di Chisholm e collaboratori (2016). Dimostrate l'attuabilità e la sostenibilità, la parte che segue definisce il sistema di monitoraggio e di valutazione ex post.

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte L

Monitoraggio, valutazione ed ex post

Sistema di indicatori, protocollo e baseline, valutazione controfattuale, verifica ex post, indicatori compositi

Verifica ex post · cunei progressivi e clausola valutativa · fondamento empirico delle stime

Parte L — Monitoraggio, valutazione ed ex post

Questa parte organizza la misurazione dell'intervento nel tempo, ed è il passaggio che distingue una riforma argomentata da una riforma dimostrata. Essa serve ex post i criteri della griglia di giudizio, chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione e, soprattutto, fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti.^{[1350][1351][1352][1353][1354][1355][1356][1357][1358][1359][1360][1361][1362][1363][1364][1365]}

^{[1366][1367][1368]} Per la Toscana vale una circostanza peculiare, che merita di essere enunciata: il servizio è già attivo in via sperimentale e ha prodotto i primi dati di esito, sicché la misurazione non è da avviare da zero ma da strutturare e completare, e il confronto prima-dopo l'attivazione del settembre 2024, insieme all'estensione scaglionata della sperimentazione tra le strutture, offre il fondamento di un disegno quasi a cunei progressivi. Le parti seguenti definiscono gli strumenti: il sistema di indicatori (capitolo L.1), il protocollo che li alimenta e la baseline (L.2), la valutazione controfattuale che ne trae prove causali (L.3), la verifica ex post della norma (L.4) e gli indicatori compositi che ne sintetizzano i risultati nel cruscotto (L.5).

L.1 Il sistema di indicatori

Il sistema di indicatori è costruito sull'ossatura del modello di Donabedian per la qualità dell'assistenza, che distingue le dimensioni di struttura — le risorse e l'organizzazione — di processo — le attività svolte — ed esito — i risultati di salute — qui integrate da una quarta dimensione, l'impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società.^[1369] Su questa ossatura si dispone una batteria di circa cinquantotto misure, articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti e dai dati della sperimentazione attiva, e circa quaranta richiedono la rilevazione diretta strutturata.^[1370] La selezione delle misure non è arbitraria, ma orientata dal principio della parsimonia: l'iniziativa internazionale per i set di esiti essenziali e i relativi standard individuano, mediante consenso strutturato, un nucleo condiviso e parsimonioso di esiti, evitando la proliferazione di misure ridondanti.^[1371] Misurare molto non equivale a misurare bene. La tabella seguente riepiloga le otto categorie e lo stato della rispettiva baseline.^[1372]

Categoria	Esempi di indicatori	Baseline
Bisogno e domanda	Prevalenza del disagio, utenza dei servizi, accessi impropri	Disponibile
Accesso ed equità	Tempo di attesa, copertura, divari tra Aziende USL	Da rilevare
Processo	Sedute erogate, cicli completati, abbandoni	Parziale
Esito clinico	Recupero, miglioramento affidabile, mantenimento	Parziale
Economici	Risparmi per canale, costo per esito	Misto
Impatto sociale	Produttività, benessere, indicatori territoriali	Misto
Organizzativi	Reclutamento, formazione, fedeltà al modello	Da rilevare
Variabili di sintesi	Indici compositi di esito e di valore	Da calcolare

Tabella L.1. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline. La sperimentazione già attiva fornisce una base parziale di dati di processo ed esito.

L.2 Il protocollo di rilevazione e la baseline

Perché gli indicatori siano calcolabili occorre un protocollo di rilevazione, ed è questo l'elemento operativo che struttura e completa la misurazione già avviata. Il protocollo è minimo — deliberatamente essenziale, per non gravare sull'attività clinica — e attivo dal primo giorno: si registrano la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni.^[1373] Gli strumenti di esito sono validati e di uso internazionale: il questionario sulla salute del paziente a nove voci e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci, impiegati — si ribadisce — nei soli punteggi complessivi.^[1374] La scelta di raccogliere le misure a ogni seduta, e non solo all'inizio e alla fine, segue il modello dei programmi inglesi: è ciò che consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non prostrarre percorsi inefficaci.^[1375]

Alla rilevazione si lega la costituzione della baseline, ossia la fotografia dello stato di partenza senza la quale nessun effetto sarebbe misurabile. La baseline si costituisce su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti forniscono la fotografia del prima, cui in Toscana si aggiunge, quale base preziosa per il confronto prima-dopo, il periodo anteriore all'attivazione del settembre 2024; la rilevazione strutturata di servizio completa quella già avviata.^[1376] Il calendario disciplina questa sequenza, dalla costituzione della baseline alla registrazione corrente, alla trasmissione mensile di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale, fino al calcolo periodico delle misure di sintesi e all'aggiornamento del cruscotto.^[1377] La tabella seguente lo riepiloga.

Momento	Attività
Baseline (dati disponibili e periodo pre-settembre 2024)	Costituzione della fotografia di partenza; valorizzazione del periodo anteriore all'attivazione per il confronto prima-dopo
Rilevazione corrente	Registrazione strutturata di ogni presa in carico e di ogni seduta, con i punteggi di esito
In continuo	Alimentazione del registro; trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale con cadenza mensile
Periodico (semestrale e annuale)	Calcolo delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale

Tabella L.2. Il calendario della rilevazione. In Toscana il periodo anteriore all'attivazione del settembre 2024 funge da base per il confronto prima-dopo.

L.3 La valutazione controfattuale

Il monitoraggio continuo dice se gli indicatori migliorano; non dice, da solo, se a migliorarli sia stato l'intervento. A questa domanda risponde la valutazione controfattuale d'impatto, che misura l'effetto causale confrontando gli esiti dei trattati con il controfattuale — ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente. Poiché il servizio è già attivo in via sperimentale e si è esteso in modo scaglionato, lo strumento non è un dispiegamento da zero, ma il confronto prima-dopo l'attivazione del settembre 2024 e l'estensione progressiva tra le strutture e le zone, che insieme configurano un disegno quasi a cunei progressivi idoneo a misurare gli effetti reali del servizio.^[1378] Il metodo principale è la differenza-nelle-differenze, che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le strutture attivate prima e quelle attivate dopo, e a maggiore e minore intensità di copertura, sotto l'ipotesi di andamento parallelo; a esso si affianca il controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata di zone non ancora attivate o a copertura inferiore.^[1379]

L'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e l'effetto medio sui soli trattati, e la sua solidità dipende dalla validità interna — la garanzia che l'effetto sia realmente attribuibile all'intervento e non a tendenze generali — mentre la validità esterna va valutata a parte; i disegni a cunei progressivi e a esperimento naturale sono, per gli interventi di salute della popolazione, lo strumento raccomandato dalla letteratura metodologica.^[1380] La portata di questo metodo, per il presente studio, è dirimente: confrontando, ad esempio, l'andamento degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche nelle zone attivate per prime e a copertura più intensa con quello delle zone attivate più tardi, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata.^[1381] È questo il passaggio che, a regime, eleva lo studio da proposta argomentata a politica validata, e che chiude il cerchio aperto dal valore dell'informazione della Parte F; la Toscana, disponendo già di una sperimentazione attiva ed estesa in modo scaglionato, è nella posizione di compiere questa verifica con un disegno particolarmente robusto.

L.4 La verifica ex post della norma

La misurazione tecnica si salda al ciclo della regolamentazione mediante la verifica ex post. La verifica dell'impatto della regolamentazione, disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017, è valutazione ex post — di norma dopo un biennio — dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, e chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione: l'una stima ex ante gli effetti attesi, l'altra ne accerta ex post il conseguimento.^[1382] A essa si lega, sul piano regionale, la clausola valutativa,

che impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti. In Toscana questo legame è particolarmente solido, perché il servizio è già istituito da una legge regionale, e i risultati della sperimentazione e della successiva strutturazione possono essere portati periodicamente all’attenzione dell’organo che ha disposto il servizio, a presidio della rendicontazione democratica.^[1383]

L.5 Gli indicatori compositi e il cruscotto

L’ultima funzione del sistema è la sintesi. La molteplicità degli indicatori, necessaria all’analisi, sarebbe però di difficile lettura per il decisore: gli indicatori compositi riducono tale molteplicità a poche misure di valore complessivo, secondo un metodo codificato. Il manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione delle variabili alla normalizzazione, alla ponderazione e all’analisi di robustezza.^[1384] L’impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica ha del resto un precedente istituzionale italiano nel Benessere Equo e Sostenibile, i cui indicatori sono entrati, con la riforma del bilancio del 2016, nel ciclo della programmazione economica.^[1385] La costruzione degli indici compositi è retta da regole di coerenza e di non duplicazione: il divieto di doppia contabilizzazione impone che una grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali già adottata nella Parte E.^[1386] Il cruscotto regionale, aggiornato periodicamente, restituisce in forma sintetica le dimensioni essenziali — il guadagno di salute, il tasso di recupero, il ritorno sociale, l’equità territoriale, la riduzione delle liste di attesa e gli indicatori di sistema — senza il canale della mobilità recuperata, qui non pertinente data la condizione di regione creditrice della Toscana. La tabella seguente ne riepiloga le dimensioni.

Dimensione di sintesi	Contenuto
Guadagno di salute	Anni di vita ponderati per la qualità in salute mentale
Tasso di recupero	Miglioramento clinico e superamento delle soglie (PHQ-9, GAD-7)
Ritorno sociale	Valore sociale generato per euro investito (SROI)
Equità territoriale	Esito e accesso tra le tre Aziende USL e tra area metropolitana centrale e aree interne e montane
Liste di attesa	Riduzione dei tempi di attesa e tenuta dell’offerta territoriale
Indicatori di sistema	Esito, esperienza, costo e operatori (Quadruple Aim)

Tabella L.3. Le dimensioni di sintesi del cruscotto regionale toscano.

Definiti gli strumenti della misurazione, lo studio dispone di tutto l’occorrente per accertare nel tempo gli effetti della riforma. La Parte M ne ricompone i risultati in una valutazione multidimensionale e formula le raccomandazioni conclusive.

STUDIO REGIONALE · REGIONE TOSCANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Griglia OCSE-DAC, analisi multi-criterio, sintesi del valore e raccomandazioni, limiti e agenda di ricerca

Sintesi conclusiva · caso strategico del Five Case Model · griglia di giudizio OCSE-DAC

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa è la parte conclusiva dello studio, e ha una funzione diversa da tutte le precedenti: non aggiunge una nuova analisi, ma ordina quelle già svolte in un giudizio. Lo strumento di questo giudizio è la griglia dei criteri dell'OCSE-DAC, che attraversa l'intero studio come metro di valutazione e converge qui nella sintesi; la parte fornisce inoltre il contenuto del caso strategico del Five Case Model.^{[1387][1388][1389][1390][1391][1392][1393][1394][1395][1396][1397][1398][1399][1400][1401][1402]} Le precedenti cornici del telaio dicono che cosa valutare, come decidere e come riportare l'economia; mancava la griglia rispetto alla quale l'intervento è infine giudicato, e la parte la applica (capitolo M.1), la integra con l'analisi multi-criterio per i criteri non monetari (M.2), ne ricava una sintesi del valore e raccomandazioni per il decisore (M.3) e ne dichiara, con franchezza, i limiti e l'agenda di ricerca (M.4).

M.1 La griglia di valutazione OCSE-DAC

I criteri dell'OCSE-DAC sono sei lenti complementari che, insieme, danno un quadro complessivo dell'intervento e dei suoi risultati: la rilevanza rispetto al bisogno, la coerenza con le altre politiche, l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse, l'impatto più ampio e la sostenibilità nel tempo.^[1403] Essi operano in due momenti dello studio: ex ante orientano la valutazione complessiva, poiché ciascun criterio diventa una domanda a cui le parti analitiche forniscono la risposta; ex post strutturano la verifica dei risultati, già trattata nella Parte L. La griglia, in tal modo, non si sovrappone all'analisi economica o ai domini della valutazione di tecnologia sanitaria, ma li ordina in un giudizio.

Applicata a questo studio, la griglia restituisce un giudizio convergente, con una sola qualificazione, propria del caso toscano, sul criterio dell'efficienza. L'intervento è rilevante, perché risponde a un bisogno reale e di grande dimensione e all'obbligo di garantire i livelli essenziali;^[1404] è coerente, perché compatibile con gli standard dell'assistenza territoriale, con il PNRR e con la legge regionale che già ne ha istituito la funzione, ed è costituzionalmente difendibile, senza incontrare il vincolo del piano di rientro;^[1405] è efficace, perché l'evidenza internazionale ne documenta il raggiungimento degli obiettivi clinici, corroborata dai dati della sperimentazione attiva;^[1406] è efficiente in termini di costo-utilità, con dominanza per paziente, pur a fronte di un saldo diretto lievemente negativo sul solo bilancio, di entità modesta;^[1407] ha un impatto distributivo favorevole e un ritorno complessivo di 3,8-5,5 a uno;^[1408] ed è sostenibile, sul piano finanziario e organizzativo, con la strutturazione a regime quale leva decisiva, essendo la legge già vigente.^[1409] La tabella seguente riepiloga il giudizio, criterio per criterio.

Criterio	Domanda valutativa	Giudizio dallo studio
Rilevanza	Risponde al bisogno reale?	Sì: ~730.000 con disagio inevaso; obbligo dei livelli essenziali
Coerenza	È compatibile con le altre politiche?	Sì: DM 77, PNRR, legge regionale dedicata (L.R. 39/2022) e regolamento; difendibile in Costituzione; non in piano di rientro, creditrice
Efficacia	Raggiunge gli obiettivi?	Sì: evidenza internazionale (recupero ~50%) e dati della sperimentazione toscana
Efficienza	Impiega le risorse in modo proporzionato?	Sì in costo-utilità (dominanza); saldo diretto lievemente negativo a costo modesto
Impatto	Produce effetti più ampi?	Sì: riduce il gradiente territoriale; ritorno complessivo 3,8-5,5:1
Sostenibilità	I benefici e il servizio durano?	Sì: costo modesto; strutturazione a regime quale leva (legge già vigente); servizio già attivo

Tabella M.1. La griglia di giudizio OCSE-DAC applicata allo studio, criterio per criterio.

M.2 L'analisi multi-criterio

L'analisi costo-efficacia e l'analisi del ritorno sociale esprimono il valore in termini prevalentemente monetari. La decisione pubblica, tuttavia, contempera una pluralità di criteri, alcuni dei quali non riducibili a denaro: l'equità, la fattibilità, la coerenza con gli indirizzi strategici, la solidità dell'evidenza. L'analisi multi-criterio rende esplicito questo bilanciamento, attribuendo a ciascun criterio un peso e a ciascuna opzione un punteggio, e aggregandoli in un punteggio complessivo.^[1410] È il metodo che impedisce alla decisione di ridursi alla sola dimensione economica, e che al tempo stesso ne rende trasparente la logica, poiché i pesi e i punteggi sono dichiarati e sindacabili.

Il confronto è condotto tra l'opzione di intervento e l'opzione zero — il mantenimento dello status quo — su otto criteri pesati. Il risultato è netto: l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 82,65 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri a eccezione della sola fattibilità immediata, nella quale l'opzione zero — che non richiede alcuna attuazione — è superiore.^[1411] Rispetto agli altri studi regionali a saldo diretto negativo, il punteggio dell'intervento toscano è marginalmente più elevato: la circostanza che la Toscana disponga già sia di una legge regionale dedicata sia di una sperimentazione attiva con dati propri innalza i sub-punteggi di fattibilità e di robustezza dell'evidenza al di sopra di quelli degli altri contesti, e la struttura consolidata in sole tre Aziende USL ne agevola l'attuazione. Resta una preferenza netta e stabile rispetto ai pesi adottati. La tabella seguente riporta la matrice delle prestazioni.

Criterio	Peso	Interv.	Opz. zero	Δ pond.
Efficacia clinica	15%	80	30	+7,50
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	87	25	+12,40
Impatto di bilancio e sostenibilità	15%	68	50	+2,70
Equità e accesso (aree interne e montane, età anziana, dimensione multiculturale, liste di attesa)	15%	85	20	+9,75
Valore sociale	10%	87	20	+6,70
Fattibilità e implementabilità (legge approvata e sperimentazione attiva)	10%	88	100	-1,20
Robustezza dell'evidenza (dati operativi propri)	10%	82	60	+2,20
Coerenza strategica (DM 77, PNRR, legge regionale dedicata)	5%	92	25	+3,35
Punteggio complessivo ponderato	100%	82,65	39,25	+43,40

Tabella M.2. Analisi multi-criterio: confronto tra l'*****opzione di intervento e l'*****opzione zero su otto criteri pesati.

M.3 La sintesi del valore e le raccomandazioni

La sintesi del valore si lascia condensare in tre affermazioni, che costituiscono il cruscotto decisionale della riforma in Toscana. La prima: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, dell'ordine di alcune decine di milioni, trascurabile rispetto a un finanziamento dell'ordine di 8 miliardi, pur con una salienza diretta non nulla nel contesto delle liste di attesa. La seconda: il ritorno per la collettività è ampio, con un rapporto beneficio-costi dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. La terza: il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali — la produttività, il funzionamento, il minor carico familiare — e non sul risparmio per il bilancio.^[1412] È questa la corretta rappresentazione della proposta toscana: non un investimento che si ripaga sui conti sanitari, ma un investimento sociale ad alto rendimento, il cui costo per il bilancio è trascurabile.

Da questa sintesi discende la raccomandazione centrale, ed è in essa che il caso toscano si distingue. La decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già istituita dalla legge regionale 39 del 2022 e attiva in via sperimentale — né se dotarla di una legge, già esistente, ma se portarla dalla sperimentazione alla strutturazione a regime, convertendo gli incarichi libero-professionali in un rapporto convenzionale analogo a quello dei medici di medicina generale, e dimensionarla, portandola dalla copertura attuale, dell'ordine del 5% del fabbisogno, alla copertura sistematica, dell'ordine di 600 incarichi nello scenario di base.^[1413] La sintesi del valore è letta, infine, lungo le cinque dimensioni del Quintuple Aim — l'esito di salute, l'esperienza della persona, il costo, il benessere degli operatori e l'equità — che ricompongono in un quadro unitario i risultati delle parti analitiche.^[1414] La raccomandazione operativa è di strutturare a regime il servizio esistente, convertendo gli incarichi libero-professionali in rapporto convenzionale, e di procedere a un dimensionamento progressivo, estendendo la rilevazione strutturata già avviata e la valutazione controfattuale fondata sul confronto prima-dopo e sull'estensione scaglionata.

M.4 I limiti e l'agenda di ricerca

La credibilità di una valutazione si misura anche dalla franchezza con cui ne dichiara i limiti. Il limite principale di questo studio è il radicamento nei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione toscana, pari al 6,2%, e non estratte dai conti regionali certificati. È una distinzione che lo studio dichiara apertamente, perché la sostituzione di tali ricostruzioni con i valori certificati delle tre Aziende USL e delle quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie è la condizione per la presentazione della proposta agli organi di controllo; in Toscana tale sostituzione è agevolata dalla disponibilità dei dati della sperimentazione già attiva.^[1415] A esso si aggiungono cautele di trasferibilità e di fonte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la cifra del ritorno è inoltre prudenziale e non ponderata per l'equità, e potrebbe perciò risultare conservativa.^[1416]

Da questi limiti discende l'agenda di ricerca. L'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso le tre Aziende USL e le quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, seguito dalla strutturazione della rilevazione di servizio e dalla valutazione controfattuale fondata sul confronto prima-dopo l'attivazione del settembre 2024 e sull'estensione scaglionata tra le strutture.^[1417] È il programma che trasforma progressivamente la proposta argomentata in politica validata, e che salda la valutazione ex ante alla verifica ex post. Con questa parte si chiude lo studio regionale toscano, che applica al contesto della Toscana, con piena fedeltà metodologica e con le dovute qualificazioni di onestà, il medesimo telaio integrato già adottato per la Puglia, per la Lombardia, per il Veneto, per l'Emilia-Romagna e per il Piemonte: un intervento clinicamente fondato, economicamente sostenibile, equo e attuabile, il cui valore per la collettività è ampio e il cui costo per il bilancio è trascurabile, e la cui combinazione di una legge regionale già vigente, di una sperimentazione attiva e di una struttura consolidata in sole tre Aziende USL ne fa un riferimento nazionale per la fase di strutturazione a regime e di implementazione uniforme.

STUDIO REGIONALE · REGIONE TOSCANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge e dalla sperimentazione al servizio strutturato a regime

Appendici A-E

Corredo tecnico e documentale

Caso di riferimento, strumenti di esito, dati regionali, standard di reporting, glossario

Materiali a sostegno delle Parti da A a M

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l'orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità.^{[1418][1419][1420][1421][1422][1423][1424][1425][1426]} La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Servizio attuale (sperimentazione) o assenza del servizio a regime
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Azienda USL/zona-distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudentiale	Riduzione per l'ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura.^[1427] La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato della Toscana, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.^[1428] La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 400	~ 600	~ 790
Costo del servizio	~ 22	~ 33	~ 44
Risparmi diretti (SSR)	~ 14	~ 22	~ 34
Ricadute economico-sociali	~ 71	~ 133	~ 207
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -8	~ -11	~ -10
Saldo complessivo (caso economico)	+63	+122	+197
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell'esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario.^[1429] La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura.^[1430] La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori toscani impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.^[1431]

Ambito	Valore regionale
Popolazione regionale	3.657.716 abitanti (Censimento ISTAT 2024); in lieve calo e con marcato invecchiamento, tra le più anziane d'Italia (età media ~50; over-65 ~26%); stranieri ~12%
Finanziamento del SSR	Dell'ordine di 8 miliardi di euro; sotto pressione finanziaria; nessun piano di rientro in atto
Mobilità sanitaria	Saldo nettamente attivo (~ +58 milioni nel 2023); regione creditrice, tra le più attrattive d'Italia; attrazione trainata dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie
Pronto soccorso	Dell'ordine di oltre un milione di accessi/anno
Farmaceutica	Consumo regionale delle categorie dei psicofarmaci
Salute mentale	~ 730.000 con disagio comune; ~ 52.000 in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale
Funzione attuale	Servizio di psicologia di base istituito dalla legge regionale 39/2022 e dal regolamento (DGR 43/2024); sperimentazione attiva da settembre 2024 in ventuno strutture; ~ 2.300 cittadini in diciotto mesi; base libero-professionale; legge dedicata già vigente; ~ 5% del fabbisogno

Tabella C.1. I valori regionali di ancoraggio della Toscana.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione toscana, e non estratti dai conti regionali certificati.^[1432] La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Dati della sperimentazione	Prese in carico, sedute ed esiti già registrati dalla sperimentazione attiva dal settembre 2024
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Azienda USL e per area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[1433] La tabella seguente li riepiloga.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.^[1434] Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra gruppi a diversa esposizione
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità a minore esposizione
Disegno a cunei progressivi e intensità di copertura	Disegno controfattuale impiegato in Toscana, ove il servizio è già attivo in via sperimentale, fondato sul confronto prima-dopo settembre 2024 e sull'estensione scaglionata tra le strutture

Termine	Definizione
Analisi e verifica d’impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta a riferire al Consiglio sui risultati della riforma
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell’implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall’impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d’ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l’intensità dell’intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; in Toscana il saldo è nettamente attivo (regione creditrice)
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di concentrazione	Misura che lega l’esito di salute alla posizione socio-economica
Peso morto	Quota dell’esito che si sarebbe verificata anche senza l’intervento

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

73

73

Lazio — Studio HTA integrale

Studio integrale Lazio · Frontespizio e indice generale

Studio integrale Lazio · Frontespizio e indice generale

PROGETTO «PSICOLOGO DI BASE» · REGIONE LAZIO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all’istituzione del servizio strutturato a regime

Studio Integrale Regionale

Frontespizio e indice generale

L’applicazione del telaio integrato alla Regione Lazio, in undici parti e cinque appendici

Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC

Documento di apertura e navigazione del corpus

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione Lazio sulla riforma «Psicologo di Base». Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell’intero corpus: la premessa, l’indice generale di tutte le parti e di tutte le appendici, la mappa di integrazione delle cornici metodologiche e la sintesi del valore. Il Lazio occupa, nel panorama nazionale, una posizione peculiare e per molti versi paradossale: è la culla scientifica del modello — il modello dello psicologo nelle cure primarie è stato elaborato a Roma — ma, a differenza di altre regioni, non ha ancora una legge regionale che istituisca il servizio. Pendono in Consiglio una proposta di legge di iniziativa consiliare e una di iniziativa popolare di analogo oggetto, e la scorsa legislatura ha conosciuto una prima esperienza nei Punti Unici di Accesso, senza però che si sia approdati a una disciplina dedicata. La decisione rilevante non è dunque se il modello sia valido, né dove sia nato, ma se la regione che ne è la culla intenda finalmente istituirlo per legge e dimensionarlo a regime, colmando la distanza fra la paternità scientifica di un’idea e la sua realizzazione istituzionale, nella regione più popolosa dell’intera serie e fortemente concentrata sull’area metropolitana di Roma.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l’alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l’ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell’intero corpus, che può essere percorso nell’ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, verifica empirica, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, cronoprogramma, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, controfattuale prospettico, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazioni, condizioni, conclusione
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati regionali e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — lievemente negativo per il Lazio, regione dal saldo di mobilità passivo la cui fuga è però concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica e non nella domanda psicologica territoriale, sicché il canale del recupero della mobilità è solo marginalmente pertinente a questo intervento — e il saldo complessivo, ampiamente positivo. La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 34	~ 51	~ 68
Risparmi diretti (SSR)	~ 22	~ 34	~ 53
Ricadute economico-sociali	~ 110	~ 207	~ 320
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -12	~ -17	~ -15
Saldo complessivo (caso economico)	+98	+190	+305
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante, per il Lazio, è approvare la legge istitutiva del servizio di psicologia di base e istituire il servizio ex novo, dotandolo dal principio di una forma stabile, di un rapporto convenzionale ben definito e di un dimensionamento adeguato, e procedere per gradi dalla prima fase di avvio — dell'ordine di 255 incarichi, corrispondente alla dotazione delle proposte di legge — verso la copertura sistematica, dell'ordine di 930 psicologi nello scenario di base e di 1.230 in quello espansivo. Il limite principale è il radicamento dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione laziale, del 9,7%, e non estratte dai conti regionali certificati delle dieci Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliero-universitarie; la loro sostituzione con dati certificati è la condizione per la presentazione agli organi di controllo, ed è nel Lazio, a differenza della Toscana, ancora non mitigata da dati operativi, poiché il servizio non è stato ancora istituito.

Lo studio si fonda, sul piano comparativo, sui programmi internazionali più autorevoli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie — il programma inglese di terapie psicologiche, il modello olandese, l'iniziativa australiana e il Collaborative Care statunitense — dei quali mutua le evidenze di efficacia e di costo-efficacia, adattandole con cautela al contesto laziale. La condizione propria del Lazio — una regione che del modello è la culla scientifica ma che deve ancora istituirlo per legge — le conferisce un pregio metodologico peculiare: la possibilità di disegnare la valutazione controfattuale fin dalla legislazione, come un esperimento a cunei progressivi prospettico tra le dieci Aziende, il più pulito realizzabile nell'intera serie regionale, capace di rilevare una linea di base prima dell'avvio e di trasformare le stime in prove via via che il servizio si estende. Su questa base, e con la dichiarazione trasparente dei propri limiti, il corpus consegna al decisore un quadro completo e onesto su cui deliberare, e alla regione che il modello ha generato l'occasione di chiudere il cerchio fra l'idea e la sua istituzione.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LAZIO · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all'istituzione del servizio strutturato a regime

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell'HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per il Lazio, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Toscana e alla Liguria. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati al Lazio. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). È la parte che rende lo studio insieme rigoroso, riproducibile e confrontabile con quelli delle altre Regioni della serie.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Servizio di Psicologia di Base nelle cure primarie del Lazio, inteso come istituzione e strutturazione a regime di una funzione che la regione non ha ancora istituito per legge, ma di cui è la culla accademica e per la quale sono oggi depositate una proposta di legge di iniziativa consiliare e una di iniziativa popolare.^[1435] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sull'approvazione della legge e sull'istituzione del servizio. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante, per il Lazio, non è strutturare a regime un servizio già esistente, ma istituirlo ex novo dotandolo dal principio di una forma stabile e di un dimensionamento adeguato, a fronte di un fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 1.230 psicologi nello scenario espansivo. Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala. Va segnalato sin d'ora che la dotazione indicata dalle proposte di legge, dell'ordine di 14 milioni di euro l'anno, corrisponde a un punto d'ingresso iniziale, inferiore allo stesso scenario conservativo qui considerato, che rappresenta invece il regime verso la copertura piena.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 1.150.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai servizi, in un quadro segnato da componenti convergenti — il disagio connesso al lavoro e alle condizioni di vita nella vasta area metropolitana romana, il disagio giovanile, il bisogno dell'età anziana accentuato nelle province interne e una rilevante dimensione multiculturale — cui si aggiunge la pressione delle liste di attesa. La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti laziali con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è lo psicologo di base nelle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, istituito e portato a regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale il servizio non è ancora istituito per legge né strutturato a regime, e in cui sono in itinere le proposte di legge. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario del Lazio, con le sue dieci Aziende Sanitarie Locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS, e la rete delle Case della Comunità in costruzione. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per il Lazio
Popolazione	Residenti laziali con disagio psichico comune (~1.150.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Psicologo di base nelle cure primarie, primo livello e filtro, istituito e portato a regime (~620/930/1.230 incarichi); istituzione ex novo del servizio
Confronto	Condizione attuale: assenza di un servizio strutturato e di una legge dedicata; proposte di legge in itinere (iniziativa consiliare e popolare); pregressa esperienza nei Punti Unici di Accesso
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale del Lazio; dieci Aziende Sanitarie Locali, aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS, rete delle Case della Comunità in costruzione

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell'HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell'OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l'intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e l'assenza del servizio strutturato come comparatore. Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Aziende Sanitarie Locali e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni, segnatamente fra l'area metropolitana romana e le province interne.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale, ovvero assenza di un servizio strutturato e di una legge dedicata, con proposte di legge in itinere
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda Sanitaria Locale e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. Tale prudenza assume, per il Lazio, un rilievo particolare e di segno definito. Il profilo di mobilità è bidirezionale: la regione è al tempo stesso forte attrattore, trainata dalle grandi strutture romane, e fonte di una rilevante mobilità passiva, con un saldo netto negativo ma in miglioramento; poiché la fuga riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica, e non la domanda psicologica, il canale del recupero della mobilità non costituisce qui una leva di risparmio significativa per questo intervento. A ciò si aggiunge che il Lazio è in uscita da un lungo piano di rientro, con i conti riportati in attivo e l'autonomia fiscale recuperata, e ha dunque appena riacquisito margini di programmazione. Ne consegue che il saldo diretto risulta lievemente negativo e che il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, che lo studio stima con criteri conservativi; in un contesto di liste di attesa, peraltro, il contenimento della domanda impropria conserva una salienza diretta. Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati, e che il Lazio, a differenza della Toscana, non dispone ancora di un servizio a regime che produca dati di esito propri.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post. Per il Lazio il disegno controfattuale assume una forma propria e particolarmente favorevole: poiché il servizio non è ancora attivo a regime, esso può essere progettato fin dall'inizio come un esperimento a cunei progressivi tra le dieci Aziende Sanitarie Locali, con l'effetto causale stimato dai metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico. La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, le dieci Aziende Sanitarie Locali, le aziende ospedaliero-universitarie, i grandi IRCCS e policlinici, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei romani, primo fra tutti la Sapienza, nel cui ambito il modello è stato elaborato. A differenza del Veneto, il Lazio non dispone di un'azienda regionale unica di coordinamento, e a differenza della Toscana presenta una struttura ampia e policentrica: dieci Aziende Sanitarie Locali, sei nell'area metropolitana romana e quattro provinciali, affiancate da numerose aziende ospedaliere e IRCCS, con il coordinamento in capo alla Regione. Poiché il servizio non è ancora istituito, e la rete territoriale delle Case della Comunità è in costruzione, la sfida del governo è di istituire e dimensionare il servizio ex novo, garantendo l'omogeneità attuativa in un sistema esteso: è il tratto che distingue il Lazio e che la valutazione assume come punto di partenza.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici; l'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per la loro adozione. Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto del Lazio.

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all’istituzione del servizio strutturato a regime

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi e cornice normativa

Primo dominio dell’HTA · il problema di salute e il suo contesto

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto del Lazio. La struttura è quella già adottata per le altre regioni della serie, e mutano soltanto i dati, ancorati alla regione. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall’epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l’intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico del Lazio: non un servizio già istituito da strutturare, ma un servizio ancora da istituire in una regione che ne è la culla scientifica, grande, policentrica e fortemente accentrata su Roma, e da poco uscita da un lungo piano di rientro.

B.1 Quadro demografico

Il Lazio conta 5.709.178 residenti, pari a circa il 9,7% della popolazione nazionale ed è la regione più popolosa tra quelle finora esaminate, in lieve calo per effetto di un saldo naturale fortemente negativo, solo in parte compensato dalle migrazioni. La struttura per età è in moderato invecchiamento, su valori inferiori a quelli delle regioni più anziane, ma con forti disomogeneità interne: più contenuto nell’area metropolitana, più marcato nelle province interne di Rieti e Viterbo. La componente straniera, pari all’11,4%, è superiore alla media nazionale ed è il flusso migratorio a sostenere la popolazione. La distribuzione è fortemente concentrata: la Città Metropolitana di Roma Capitale raccoglie circa tre quarti dei residenti, con una marcata polarità fra l’area metropolitana e le province interne in spopolamento. La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per il Lazio
Popolazione (Censimento 2024)	5.709.178 (~9,7% del totale nazionale); in lieve calo per saldo naturale negativo
Età media e invecchiamento	~ 46,7 anni, in crescita; più contenuto della media delle regioni anziane; marcato nelle province interne
Componente straniera	11,4% dei residenti, superiore alla media nazionale; sostiene la popolazione
Distribuzione territoriale	Città Metropolitana di Roma Capitale ~74%; Latina ~9,9%, Frosinone ~8,1%, Viterbo ~5,4%, Rieti ~2,6%
Profilo territoriale	Vasta area metropolitana con periferia ampia; province interne anziane e in spopolamento
Articolazione sanitaria	Dieci Aziende Sanitarie Locali, aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico del Lazio.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale nel Lazio è ampio e sospinto da una popolazione numerosa e fortemente urbana. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell'ordine di 1.150.000 persone, in larga parte non intercettate dall'offerta strutturata. A questa quota si somma un'ampia utenza specialistica in carico ai servizi, su un territorio che presenta una specificità unica: è la culla accademica del modello dello psicologo di base, elaborato a Roma. Tre componenti orientano la domanda. La prima è il disagio giovanile, in crescita. La seconda è il disagio connesso al lavoro nella vasta popolazione attiva metropolitana. La terza è il bisogno dell'età anziana, accentuato nelle province interne. È la combinazione — grande regione accentrata su Roma, culla scientifica del modello e posizione pre-legislativa — a distinguere il fabbisogno laziale. La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche significativi.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone, nel Lazio, un'offerta che presenta la fisionomia più arretrata della serie: il servizio di psicologia territoriale non è ancora istituito, e sono in itinere una proposta di legge di iniziativa consiliare e una di iniziativa popolare, con una dotazione stimata dell'ordine di 14 milioni di euro l'anno e un obiettivo di uno psicologo ogni quindicimila abitanti, mentre la pregressa esperienza nei Punti Unici di Accesso costituisce un precedente ma non un servizio a regime. Il fabbisogno a regime è stimato nell'ordine di 1.230 psicologi nello scenario espansivo, e l'Ordine professionale regionale ne sostiene l'approvazione. La copertura attuale è dunque pressoché nulla a regime, e la distanza dalla copertura adeguata è la più ampia dell'intera serie: non un servizio da strutturare, ma un servizio da istituire. La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per il Lazio
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 1.150.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	Ampia (alcune decine di migliaia, stima rapportata ai dati nazionali)
Offerta territoriale attuale	Servizio non ancora istituito; proposte di legge in itinere (iniziativa consiliare e popolare); pregressa esperienza nei Punti Unici di Accesso
Fabbisogno stimato a regime	~ 1.230 psicologi nello scenario espansivo (620-930 negli altri scenari)
Copertura attuale del fabbisogno	Pressoché nulla a regime; la distanza più ampia della serie

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, nel Lazio, si gioca su due assi. Il primo è interno alla vasta area metropolitana romana, fra il centro e una periferia ampia che presenta sacche di deprivazione e difficoltà di accesso. Il secondo separa l'area metropolitana dalle province interne — Rieti e Viterbo in particolare —

anziane, disperse e in spopolamento, dove la rarefazione dei servizi e le distanze acuiscono gli ostacoli all'accesso. Su questi divari il servizio di psicologia di base agisce in funzione di equità: avvicina l'offerta alle aree interne e alle periferie mediante la telepsicologia assistita — dove la sola presenza di un primo livello accessibile è già un atto di riequilibrio — e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica e contribuisce a contenere i tempi di attesa.

B.5 I servizi e i flussi

Il Servizio sanitario del Lazio dispone di risorse complessive dell'ordine di 12-13 miliardi di euro; la Regione è in uscita da un piano di rientro durato dal 2007, con i conti riportati in attivo e l'autonomia fiscale recuperata, e ha dunque appena riacquisito margini di programmazione, pur con fragilità residue nei tempi di pagamento di alcune Aziende. Il profilo di mobilità è bidirezionale: il Lazio è al tempo stesso forte attrattore, trainato dalle grandi strutture romane, e fonte di una rilevante mobilità passiva, con un saldo netto negativo ma in miglioramento; poiché la fuga riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica, il canale del recupero della mobilità è solo marginalmente pertinente a questo intervento. L'architettura dei servizi poggia su dieci Aziende Sanitarie Locali — sei nell'area metropolitana romana e quattro provinciali — su numerose aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS, e su una rete territoriale di Case della Comunità in costruzione, su cui il servizio andrà innestato. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per il Lazio
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	~ 12-13 miliardi di euro; in uscita dal piano di rientro 2007-2025; conti in attivo; autonomia fiscale recuperata
Mobilità sanitaria	Profilo bidirezionale (forte attrattore e rilevante fuga); saldo netto negativo ma in miglioramento; canale marginale come leva per questo intervento (fuga ospedaliera e chirurgica)
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche significativi (alcune decine di migliaia l'anno, stima rapportata ai dati nazionali)
Architettura dei servizi	Dieci Aziende Sanitarie Locali, aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS; rete delle Case della Comunità in costruzione; nessuna azienda regionale unica
Margine di azione principale	Istituzione del servizio, liste di attesa, accesso delle periferie e delle aree interne, intercettazione precoce della domanda

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice peculiare: il Lazio non dispone ancora di una legge regionale dedicata, ma di proposte in itinere — una di iniziativa consiliare e una di iniziativa popolare — di analogo oggetto, accompagnate dall'Ordine professionale e radicate nella tradizione scientifica del modello, nato nella regione. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale e il Piano regionale di azioni per la salute mentale; sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera, il Piano Nazionale per la Salute Mentale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021, che ha delimitato la competenza regionale in materia. La decisione rilevante, in questo contesto, non è strutturare a regime una funzione già istituita, ma approvare la legge e istituire il servizio: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all’istituzione del servizio strutturato a regime

Parte C

L’intervento e il suo modello

Definizione, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali e formazione

Secondo dominio dell’HTA · la descrizione della tecnologia

Parte C — L’intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l’intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l’intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l’interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico del Lazio emerge con nettezza: l’intervento non è da strutturare, ma da istituire ex novo, in una regione che ne è però la culla scientifica e che può perciò progettarne fin dall’inizio il modello, il sistema informativo e il monitoraggio.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire. La logica dell’intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria. Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell’ordine di 1.150.000 persone con disagio comune. La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per il Lazio
Bisogno	~ 1.150.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Psicologo nelle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell’intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo di base nelle Case della Comunità, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impianto delle proposte di legge in itinere, che prevedono uno psicologo ogni quindicimila abitanti. Il Lazio presenta qui una specificità: il servizio va istituito ex novo nelle dieci Aziende Sanitarie Locali. A differenza del Veneto, la regione non dispone di un'azienda regionale unica, e il coordinamento è in capo alla Regione, sicché garantire l'omogeneità attuativa in un sistema esteso e policentrico — sei Aziende metropolitane e quattro provinciali — è la sfida organizzativa principale. La rete territoriale delle Case della Comunità, in costruzione, è l'infrastruttura su cui il servizio andrà innestato. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, una valutazione iniziale con progetto clinico individuale, un ciclo di colloqui brevi con programma di sostegno personalizzato e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti; esso poggia su un modello clinico elaborato proprio nella regione. Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata. Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con il fascicolo sanitario elettronico regionale, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. In assenza di un'azienda regionale unica, il coordinamento informativo è in capo alla Regione, che ne deve assicurare l'uniformità fra le dieci Aziende. La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale; su questo terreno il Lazio dispone del vantaggio più netto della serie: poiché il servizio non è ancora attivo, il flusso informativo può essere progettato fin dal primo giorno in modo completo e uniforme, senza dover recuperare a posteriori dati frammentari.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale. Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile. L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica. La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, nel Lazio, lo strumento per garantire l'accesso nella vasta periferia metropolitana e nelle province interne, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza. I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici. La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle periferie e nelle aree interne; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso gli atenei romani, primo fra tutti la Sapienza, nel cui ambito il modello è stato elaborato, e inoltre Tor Vergata, Roma Tre, Cattolica e Campus Bio-Medico; il livello post-universitario specialistico attraverso una formazione dedicata alla psicologia di base e alle cure primarie, comprensiva della competenza per l'età anziana, per le aree interne e della competenza culturale per l'utenza straniera; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione. A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità, sostenuta dall'infrastruttura informatica regionale. La radice accademica del modello nella regione costituisce, per il Lazio, una base formativa peculiare. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Atenei romani (Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Cattolica, Campus Bio-Medico)
2. Post-universitario specialistico	Psicologia di base e cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, competenza per l'età anziana e culturale	Formazione dedicata
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LAZIO · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all'istituzione del servizio strutturato a regime

Parte D

Efficacia clinica ed evidenza

Metodo della revisione, evidenza di efficacia, qualità GRADE, benchmark internazionali, trasferibilità

Quarto dominio dell'HTA · l'efficacia clinica

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte affronta il quarto dominio della valutazione, l'efficacia clinica, e ne ricostruisce la base di evidenza. Come per le regioni precedenti, il corpo dell'evidenza internazionale è invariante, poiché l'efficacia di un intervento clinico non muta con i confini regionali; muta invece la base di evidenza locale, ed è qui che il Lazio presenta un tratto peculiare. La parte espone il metodo della revisione e i risultati di efficacia (capitolo D.1); ne gradua la qualità e ne dichiara una cautela economica essenziale (D.2); presenta i benchmark internazionali (D.3); e discute le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale laziale (D.4). Quest'ultima presenta una doppia natura: da un lato il Lazio è la radice italiana del modello, dall'altro non dispone ancora di un servizio attivo a regime, sicché lo studio si fonda, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, sulla tradizione scientifica del modello nella regione e sul disegno valutativo prospettico.

D.1 Il metodo della revisione e l'evidenza di efficacia

La sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale, con preferenza per le fonti più recenti. Il nucleo dell'evidenza proviene dal modello della cura collaborativa, di cui lo studio fondativo ha documentato che circa la metà dei pazienti trattati conseguiva una riduzione sostanziale dei sintomi a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura

usuale. La robustezza del risultato è confermata dalla meta-analisi su cinquantasette studi controllati, con un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a poco meno di un terzo di deviazione standard, e da una più recente revisione di quarantadue implementazioni, che documenta riduzioni rilevanti della depressione e dell’ansia e una contrazione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri. Sul versante dei dati reali, il programma inglese delle terapie psicologiche registra, su scala di oltre un milione di persone l’anno, un tasso di recupero del 50,2% e un miglioramento affidabile di oltre due terzi, con completezza dei dati di esito superiore al 98%. Anche le sintesi più caute confermano un effetto di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante sull’intera popolazione.

D.2 La qualità dell’evidenza e una cautela economica

La graduazione della certezza secondo il sistema GRADE colloca l’efficacia clinica dell’integrazione psicologica nelle cure primarie su un livello da moderato a elevato per i disturbi comuni, mentre la certezza è più eterogenea e minore per gli esiti economici, in particolare per quelli di sistema. Da questa graduazione discende una cautela che lo studio adotta come principio di onestà intellettuale, e che merita di essere enunciata senza attenuazioni: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l’intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero. Ciò significa che il valore economico del modello non può essere fondato sui risparmi sanitari diretti, ma poggia in misura preponderante sui ritorni sociali. È una cautela che, lungi dall’indebolire il caso laziale, ne corrobora la coerenza interna, poiché il caso economico del Lazio — come si vedrà nella Parte E — è fondato anch’esso sulle ricadute sociali, e non su un risparmio diretto che la regione non potrebbe rivendicare con certezza statistica.

D.3 I benchmark internazionali

L’evidenza si concretizza in quattro programmi nazionali consolidati, che costituiscono i riferimenti per il disegno del servizio. Il programma inglese delle terapie psicologiche è il riferimento principale per l’organizzazione: servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell’ordine del 50% e monitoraggio degli esiti pressoché completo. Il modello olandese integra una figura di supporto psicologico nello studio del medico di base, adottata dalla maggioranza dei medici, con ruolo complementare alla specialistica. Il modello australiano, a invio esterno, ha innalzato di oltre dieci punti la quota di popolazione in trattamento. Il modello statunitense della cura collaborativa, validato da oltre novanta studi controllati, documenta riduzioni rilevanti della depressione e dei ricoveri. La tabella seguente ne riepiloga i tratti salienti.

Programma	Modello	Risultati principali
Regno Unito (NHS Talking Therapies)	Servizio integrato a intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio esiti >98%; >1,3 milioni/anno
Paesi Bassi (POH-GGZ)	Supporto psicologico nello studio del medico di base	Adozione da ~tre quarti dei medici; ruolo complementare
Australia (Better Access)	Invio esterno a professionisti	Popolazione in trattamento dal 35% al 46%
Stati Uniti (Collaborative Care)	Équipe integrata con monitoraggio	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione, -41% ricoveri

Tabella D.1. I benchmark internazionali dell’integrazione della salute mentale nelle cure primarie.

D.4 Le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale

Sul piano nazionale, il modello dell'integrazione psicologica nelle cure primarie ha una radice italiana proprio nel Lazio, dove è stato elaborato a Roma e dove la scorsa legislatura ha conosciuto una prima esperienza nei Punti Unici di Accesso; a ciò si aggiungono i servizi avviati nelle regioni dotate di una legge dedicata, mentre i dati delle sperimentazioni storiche derivano da campioni limitati e in parte da letteratura grigia, e vanno assunti con cautela. Più in generale, i risultati internazionali provengono da sistemi diversi per organizzazione e finanziamento, e la loro trasposizione richiede validazione locale, evitando di trasferire meccanicamente le stime, soprattutto quelle economiche. È qui che la posizione del Lazio presenta una doppia natura, da dichiarare con franchezza: la regione è la radice scientifica del modello, ma a differenza della Toscana non dispone di un servizio attivo a regime e non ha quindi dati di esito propri attuali, sicché l'evidenza locale è allo stato prospettica. Ciò non costituisce, tuttavia, soltanto un limite: pur non disponendo di dati operativi attuali, il Lazio presenta un terreno favorevole alla valutazione — la tradizione scientifica del modello, l'infrastruttura informatica regionale, la rete delle Case della Comunità in costruzione — e gode del vantaggio di poter disegnare la valutazione fin dall'istituzione del servizio, generando un'evidenza locale solida e non soltanto importata. Una precisazione di metodo, infine, accompagna l'intero studio a garanzia della sua credibilità. Alcune cifre di larga circolazione — il rapporto di quattro a uno, l'affermazione per cui un euro ne genererebbe dieci, il rapporto di due e mezzo a uno talvolta richiamato in sede regionale — sono semplificazioni divulgative. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, e lo studio adotta prudenzialmente un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,8 a 5,5 a uno. Su questa base di evidenza, graduata e dichiarata nei suoi limiti, poggia la valutazione economica della Parte E.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LAZIO · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all'istituzione del servizio strutturato a regime

Parte E

Valutazione economica

Costo del servizio, risparmi diretti, ricadute sociali, saldo, costo-utilità e impatto sul bilancio

Quinto dominio dell'HTA · la valutazione economica

Parte E — Valutazione economica

Questa parte affronta il quinto dominio della valutazione, quello economico, e ne costituisce il cuore quantitativo. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i valori, ancorati al Lazio. La parte definisce l'impianto e il costo del servizio (capitolo E.1); quantifica i risparmi diretti per il bilancio sanitario, canale per canale (E.2); stima le ricadute economico-sociali per la collettività (E.3); compone il quadro consolidato, con il saldo e il rapporto beneficio-costi, tenendo ferma la distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico (E.4); presenta l'analisi costo-utilità per paziente e la sua robustezza probabilistica (E.5); e valuta l'impatto sul bilancio e la sostenibilità (E.6). Per il Lazio il risultato si lascia anticipare in una formula: il caso finanziario diretto è di modesto disavanzo, il caso economico complessivo è fortemente positivo, e il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali.

E.1 L'impianto e il costo del servizio

La valutazione economica impiega congiuntamente tre strumenti complementari — l'analisi costo-utilità, l'analisi di impatto sul bilancio e l'analisi del ritorno sociale — nella doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, che distingue i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute più ampie. Il costo del

servizio a regime, assumendo un costo medio annuo per incarico dell'ordine di 55.000 euro comprensivo degli oneri, è dell'ordine di 34 milioni di euro nello scenario conservativo, 51 milioni in quello di base e 68 milioni in quello espansivo. I tre scenari rappresentano gradi crescenti di copertura verso il fabbisogno pieno; va ribadito che la dotazione delle proposte di legge in itinere, dell'ordine di 14 milioni di euro l'anno, corrisponde a un punto d'ingresso iniziale inferiore allo stesso scenario conservativo, e non al regime qui considerato. La tabella seguente riepiloga il costo del servizio per scenario.

Scenario	Psicologi	Costo annuo	Quota del FSR
Conservativo	~ 620	~ 34 milioni	~ 0,3%
Base	~ 930	~ 51 milioni	~ 0,4%
Espansivo	~ 1.230	~ 68 milioni	~ 0,5%

Tabella E.1. Il costo del servizio a regime nei tre scenari di copertura.

E.2 I risparmi diretti per il bilancio sanitario

I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale si articolano in quattro canali. Il primo è la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, dell'ordine di 4, 6 e 8 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Il secondo è la riduzione della spesa farmaceutica inappropriata, dell'ordine di 4, 7 e 11 milioni. Il terzo, il più consistente, è la riduzione di ricoveri evitabili e di specialistica impropria, dell'ordine di 12, 19 e 32 milioni. Il quarto, il recupero della mobilità, è per il Lazio soltanto marginale e simbolico, dell'ordine di 2 milioni in tutti gli scenari: benché la regione abbia un saldo di mobilità passivo, la fuga riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica, non la domanda psicologica delle cure primarie. La somma dei quattro canali è dell'ordine di 22, 34 e 53 milioni di euro l'anno, e determina, a fronte del costo del servizio, un saldo diretto lievemente negativo, dell'ordine di -12, -17 e -15 milioni. La tabella seguente dettaglia i canali del risparmio diretto.

Canale (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Accessi impropri al pronto soccorso	~ 4	~ 6	~ 8
Spesa farmaceutica inappropriata	~ 4	~ 7	~ 11
Ricoveri evitabili e specialistica	~ 12	~ 19	~ 32
Recupero della mobilità (marginale)	~ 2	~ 2	~ 2
Totale risparmi diretti	~ 22	~ 34	~ 53
Costo del servizio	~ 34	~ 51	~ 68
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -12	~ -17	~ -15

Tabella E.2. I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale e il saldo diretto.

E.3 Le ricadute economico-sociali

Oltre i confini del bilancio sanitario, l'intervento genera ricadute economico-sociali ampie, di cui la valutazione tiene conto nella prospettiva societale. Esse comprendono il recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo, il valore del benessere recuperato e il minor carico assistenziale sulle famiglie, e sono stimate, secondo i criteri prudenziali dello studio, nell'ordine di 110, 207 e 320 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Sommate ai risparmi diretti, esse determinano un ritorno complessivo dell'ordine di 132, 241 e 373 milioni di euro l'anno, e un saldo complessivo per la collettività ampiamente positivo, dell'ordine di +98, +190 e +305 milioni. Ne discende un rapporto beneficio-costo complessivo dell'ordine di 3,9 a uno nello scenario conservativo, 4,7 a uno in quello di base e 5,5 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale adottata.

E.4 Il quadro consolidato: caso finanziario e caso economico

La composizione delle grandezze impone di tenere ferma una distinzione che governa l'intera lettura del caso laziale. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, poiché i risparmi diretti non coprono per intero il costo del servizio e il canale della mobilità è marginale. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe: si tratta di un investimento sociale, a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto per il bilancio sanitario. La tabella consolidata che segue è lo strumento sintetico per la decisione, e distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale.

Voce (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 34	~ 51	~ 68
Risparmi diretti (SSR)	~ 22	~ 34	~ 53
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -12	~ -17	~ -15
Ricadute economico-sociali	~ 110	~ 207	~ 320
Ritorno complessivo	~ 132	~ 241	~ 373
Saldo complessivo (caso economico)	~ +98	~ +190	~ +305
Rapporto beneficio-costo complessivo	~ 3,9:1	~ 4,7:1	~ 5,5:1

Tabella E.3. Il quadro economico consolidato, con la distinzione fra caso finanziario e caso economico.

E.5 L'analisi costo-utilità per paziente

Accanto alle grandezze aggregate, la valutazione conduce un'analisi costo-utilità per paziente trattato, mediante un modello di Markov a cinque anni con sconto del 3%, indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. Il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: a un tempo meno costoso e più efficace. L'analisi di sensibilità probabilistica, su diecimila simulazioni, conferma la solidità del risultato: l'intervento è

costo-efficace nell’88,9% dei casi alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell’84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell’ordine di 7.815 euro. La tabella seguente riepiloga il risultato per paziente.

Grandezza (per paziente)	Comparatore	Intervento	Differenza
Costo atteso per paziente	~ 3.799 euro	~ 2.495 euro	– 1.304 euro
Anni di vita ponderati (QALY)	3,392	3,627	+ 0,236
Esito	—	—	Intervento dominante
Costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	—	—	88,9% delle simulazioni

Tabella E.4. L’analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni).

E.6 L’impatto sul bilancio, la sostenibilità e la lacuna dei dati

Sul piano dell’impatto sul bilancio, il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta del finanziamento sanitario regionale, dell’ordine dello 0,3% nello scenario conservativo e dello 0,5% in quello espansivo; la sostenibilità è favorita dalla circostanza che il Lazio è in uscita da un lungo piano di rientro, con i conti riportati in attivo e l’autonomia fiscale recuperata, sicché la regione dispone oggi di margini di programmazione che la rendono praticabile. Resta da dichiarare con franchezza la lacuna dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti certificati delle Aziende, e il Lazio non dispone ancora di un servizio attivo che produca dati di esito propri, sicché la stima poggia sui benchmark, sulla radice scientifica del modello nella regione e sul disegno valutativo, e dovrà essere corroborata dai dati certificati e dai dati di esito raccolti a partire dall’istituzione del servizio. La sintesi è univoca: il caso diretto è prudente e di modesto disavanzo, il caso sociale è robusto e fortemente positivo, il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità, in piena coerenza con la cautela metodologica già enunciata, per cui il valore dell’intervento risiede nelle ricadute sociali e non in un risparmio di bilancio che lo studio si astiene dal rivendicare. La parte che segue sottopone questo quadro alla prova dell’incertezza e della modellazione.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LAZIO · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all’istituzione del servizio strutturato a regime

Parte F

Modellazione e incertezza

Modello decisionale, sensibilità deterministica e probabilistica, scenari, verifica empirica e valore dell’informazione

Quinto dominio dell’HTA · la robustezza della valutazione economica

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte completa il dominio economico sottoponendo i risultati della Parte E alla prova della modellazione e dell’incertezza. Come per le altre regioni, il modello è invariante e muta solo ciò che attiene alla verifica empirica locale. La parte descrive il modello decisionale e i suoi parametri (capitolo F.1); ne saggia la robustezza con l’analisi di sensibilità deterministica (F.2) e probabilistica (F.3); ne esplora gli scenari di

copertura (F.4); e definisce il disegno della verifica empirica e il valore dell’informazione (F.5). Per il Lazio quest’ultimo capitolo riveste un’importanza particolare: poiché il servizio non è ancora attivo, la prova empirica può essere disegnata fin dall’inizio nel modo metodologicamente più solido, e la posizione pre-legislativa della regione si rivela, sul piano valutativo, un vantaggio.

F.1 Il modello decisionale e i suoi parametri

Poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l’orizzonte direttamente osservabile, lo studio li proietta nel tempo mediante un modello decisionale, e ne rende esplicite le assunzioni.^{[1436][1437][1438]} La storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%.^[1439] A ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita, trattati come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l’incertezza.^[1440] Nel caso base l’intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell’ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità.^[1441] La tabella seguente riepiloga i parametri principali del modello.

Parametro del modello	Valore
Stati clinici	Benessere o sottosoglia, episodio, cronicità, recupero
Orizzonte temporale	Cinque anni, con cicli successivi
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti
Costo per ciclo (recupero)	~ 40 euro
Costo per ciclo (cronicità)	~ 700 euro
Costo dell’intervento	~ 300 euro una tantum
Trattamento dell’incertezza	Parametri come distribuzioni di probabilità

Tabella F.1. I parametri principali del modello di Markov (comune a tutti gli studi della serie).

F.2 L’analisi di sensibilità deterministica

La robustezza del risultato è saggiata, in prima istanza, variando un parametro per volta entro intervalli plausibili. La variazione dei parametri più influenti — l’efficacia dell’intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — non muta il segno del risultato, che resta favorevole all’intervento in tutti i casi esaminati.^[1442] L’ordinamento dei parametri per influenza mostra che l’esito è più sensibile all’efficacia clinica e al costo evitato della cronicità, e meno agli altri parametri; ciò orienta le priorità di raccolta dei dati verso le grandezze più influenti.^[1443]

F.3 L’analisi di sensibilità probabilistica

In seconda istanza, la robustezza è saggiata facendo variare simultaneamente tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni, su diecimila simulazioni. L’intervento risulta costo-efficace nell’88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell’84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell’ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95%

compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro.^[1444] La curva di accettabilità conferma che alla soglia convenzionale la probabilità di convenienza è prossima al 90% e cresce per soglie superiori, mantenendosi elevata anche a soglie molto inferiori.^[1445] La tabella seguente riepiloga gli esiti della sensibilità probabilistica.

Esito della sensibilità probabilistica	Valore
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	88,9% delle simulazioni
Probabilità di dominanza	84,6% delle simulazioni
Beneficio monetario netto medio per paziente	~ 7.815 euro
Intervallo di confidenza al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 euro
Numero di simulazioni	10.000

Tabella F.2. Gli esiti dell'analisi di sensibilità probabilistica (per paziente).

F.4 Gli scenari di copertura e l'incertezza aggregata

Gli scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; la dotazione delle proposte di legge in itinere corrisponde a un punto d'ingresso iniziale inferiore allo scenario conservativo, prima tappa di un percorso di estensione progressiva.^[1446] È in questa sede che va ribadita una distinzione di onestà analitica: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema.^[1447]

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

Il disegno della verifica empirica costituisce, per il Lazio, il tratto più favorevole dell'intero studio. Poiché il servizio non è ancora attivo, la verifica controfattuale può essere progettata fin dall'inizio come un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le dieci Aziende Sanitarie Locali sono stabiliti in anticipo a fini valutativi: è la condizione metodologicamente più solida dell'intera serie, poiché la regione muove dalla legislazione e non da una sperimentazione già in corso da ricostruire a posteriori.^[1448] L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il controllo sintetico, a partire da una misurazione di base anteriore all'istituzione del servizio.^[1449] L'analisi del valore dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione laziale, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle Aziende e la raccolta dei dati di esito a partire dall'istituzione del servizio.^[1450] Il disegno prospettico consente così di colmare la lacuna dei dati man mano che il servizio entra a regime, conducendo la regione, in modo programmato, da una valutazione fondata su dati esterni a una fondata su dati propri.^[1451] La sintesi è univoca: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione dei dati, e la posizione pre-legislativa si rivela, sul piano valutativo, un vantaggio. La parte che segue affronta l'equità e l'impatto distributivo.^[1452]

Priorità di ricerca	Finalità	Rilevanza
Conti certificati delle dieci Aziende e delle AOU	Sostituire le stime per quota con dati reali	Massima
Dati di esito dall'istituzione del servizio	Generare evidenza locale propria	Massima
Tassi di intercettazione e costi evitati	Ridurre l'incertezza sulle grandezze aggregate	Alta
Efficacia clinica nel contesto locale	Corroborare il parametro più influente	Alta

Tabella F.3. Le priorità di ricerca derivanti dall'analisi del valore dell'informazione.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LAZIO · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all'istituzione del servizio strutturato a regime

Parte G

Equità e impatto distributivo

Gradiente sociale, assi territoriali del divario, barriere di accesso, costo-efficacia distributiva

Dominio dell'HTA · i pazienti e l'equità

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte affronta il dominio dell'equità, che la valutazione di tecnologia sanitaria tiene distinto dall'efficienza. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i dati distributivi, ancorati al Lazio. La parte definisce il quadro dell'equità e il gradiente sociale (capitolo G.1); analizza i due assi territoriali del divario laziale e le barriere di accesso (G.2); descrive gli strumenti attraverso cui il servizio agisce sull'equità (G.3); e presenta l'analisi di costo-efficacia distributiva con le sue implicazioni allocative (G.4). Il tratto distintivo del Lazio è la doppia struttura del divario: non un solo asse, ma due — centro e periferia entro l'area metropolitana, e area metropolitana contro province interne — che l'intervento può ridurre, a condizione di un'allocazione modulata per il bisogno.

G.1 Il quadro dell'equità e il gradiente sociale

L'analisi distributiva costituisce un dominio proprio della valutazione, poiché un intervento efficiente nel complesso può nondimeno accrescere o ridurre le disuguaglianze; lo studio ne misura l'effetto con l'analisi di costo-efficacia distributiva.^{[1453][1454][1455][1456][1457][1458][1459][1460][1461][1462][1463][1464][1465][1466]} Il punto di partenza è il gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori.^[1467] A questo gradiente si sommano barriere di accesso economiche, geografiche e culturali, oltre allo stigma; nel Lazio la componente straniera, concentrata nell'area romana, aggiunge una barriera linguistica e culturale che richiede competenza dedicata.^[1468]

G.2 I due assi del divario territoriale

La specificità distributiva del Lazio risiede nella doppia struttura del divario.^[1469] Il primo asse è interno alla vasta area metropolitana romana: accanto a quartieri centrali ben serviti si estendono periferie popolate con sacche di deprivazione socio-economica, dove la difficoltà di accesso e la minore disponibilità di offerta privata accrescono il bisogno non intercettato.^[1470] Il secondo asse separa l'area metropolitana dalle province interne: Rieti e Viterbo, e le aree montane e collinari interne, presentano una popolazione più anziana, dispersa e in spopolamento, dove la rarefazione dei servizi e le distanze rendono l'accesso al sostegno psicologico particolarmente difficoltoso.^[1471] La tabella seguente sintetizza i due assi e le leve di riequilibrio.

Asse del divario	Caratterizzazione	Leva di riequilibrio
Centro / periferia metropolitana	Periferie romane popolate con sacche di deprivazione e minore offerta privata	Sedi nelle Case della Comunità di periferia; allocazione pro-equità
Area metropolitana / province interne	Rieti, Viterbo e aree montane: popolazione anziana, dispersa, in spopolamento	Telepsicologia assistita; presenza programmata di primo livello
Popolazione straniera	Barriera linguistica e culturale, concentrata nell'area romana	Mediazione linguistica e competenza culturale

Tabella G.1. I due assi del divario territoriale laziale e le leve di riequilibrio.

G.3 Gli strumenti dell'equità

Il servizio agisce sull'equità attraverso meccanismi precisi. La gratuità, la prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano le principali barriere e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso.^[1472] La telepsicologia assistita avvicina l'offerta alle province interne e alle periferie metropolitane, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, estendendo la copertura proprio dove l'accesso è più difficile.^[1473] La competenza culturale e la mediazione linguistica assicurano che la barriera linguistica non si traduca in un minore accesso per la popolazione straniera, condizione di equità particolarmente rilevante nell'area romana.^[1474]

G.4 La costo-efficacia distributiva e le implicazioni allocative

L'analisi di costo-efficacia distributiva indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, poiché i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto.^[1475] Perché questo potenziale si realizzi, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle periferie metropolitane e alle province interne: un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un'allocazione ponderata per il bisogno li riduce.^[1476] Va inoltre tenuto presente che, nel Lazio, il canale della mobilità non costituisce una leva di equità per questo intervento, sicché l'equità si gioca interamente sull'accesso interno.^[1477] Esiste infine un rischio di iniquità inversa: se l'istituzione del servizio privilegiasse, per facilità organizzativa, le aree già meglio servite del centro, l'effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell'allocazione, fin dalla fase di istituzione.^[1478] La sintesi è che l'intervento è favorevole all'equità su entrambi gli assi, a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno e che siano

garantite la telepsicologia per le aree interne e la competenza culturale per l’utenza straniera; la raccomandazione è di adottare, fin dall’istituzione, un’allocazione pro-equità.^[1479] La tabella seguente riepiloga l’impatto distributivo atteso.

Dimensione distributiva	Esito per il Lazio
Efficienza complessiva	Intervento costo-efficace e dominante per paziente
Direzione dell’effetto distributivo	Favorevole all’equità: maggiori benefici nei gruppi a più alto bisogno
Condizione di realizzazione	Allocazione modulata per il bisogno (periferie e aree interne)
Strumenti abilitanti	Gratuità, prossimità, telepsicologia, competenza culturale
Rischio da prevenire	Iniquità inversa da allocazione orientata alla facilità organizzativa

Tabella G.2. L’**impatto distributivo atteso dell’intervento e le sue condizioni.**

STUDIO REGIONALE · REGIONE LAZIO · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all’istituzione del servizio strutturato a regime

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Competenza e forma dell’atto, rapporto di lavoro, governance, tutele etiche e protezione dei dati

Domini dell’HTA · aspetti giuridici, etici e organizzativi

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte affronta congiuntamente i domini giuridico, organizzativo ed etico, che la valutazione tiene distinti ma interdipendenti. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati al Lazio. La parte tratta il profilo giuridico — la competenza, la forma dell’atto, il rapporto di lavoro e i livelli essenziali (capitolo H.1); il profilo organizzativo — l’assetto e la governance dell’istituzione (H.2); il profilo etico — le tutele a garanzia dei pazienti (H.3); e la sintesi dei tre profili (H.4). Il tratto distintivo del Lazio emerge sul piano giuridico: a differenza delle regioni già dotate di una legge, la condizione abilitante dell’intervento è qui l’approvazione della legge istitutiva, che la regione deve ancora compiere.

H.1 Il profilo giuridico

La fattibilità dell’intervento dipende dal presidio congiunto dei tre profili, una debolezza in uno solo dei quali ne comprometterebbe l’esito.^{[1480][1481][1482][1483][1484][1485][1486][1487][1488][1489][1490][1491][1492][1493][1494][1495]} Sul piano giuridico, la materia si colloca nella competenza concorrente in tema di tutela della salute, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 ne ha delimitato lo spazio regionale, che deve esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali statali: il Lazio dispone quindi del titolo per istituire il servizio con legge propria, purché coordinata con la cornice nazionale.^[1496] Qui si colloca la specificità della regione: non disponendo di una legge dedicata, ma di una proposta di iniziativa consiliare e di una di iniziativa popolare, la decisione giuridica rilevante è l’approvazione della legge istitutiva, presupposto formale dell’intero intervento.^[1497] Il rapporto di lavoro prevalente, anche nelle proposte in itinere, è quello convenzionale su base

libero-professionale, per analogia con la medicina generale, da presidiare sul piano delle tutele e della continuità.^[1498] Quanto ai livelli essenziali di assistenza, la psicologia di base non vi è ancora esplicitamente ricompresa, ma la Regione può istituirla con risorse proprie, e un futuro riconoscimento ne rafforzerebbe la stabilità finanziaria.^[1499] Il servizio si inserisce coerentemente nella cornice degli standard territoriali e delle Case della Comunità,^[1500] e si rapporta ai Centri di Salute Mentale per integrazione e non per sovrapposizione, precedendoli e alleggerendoli.^[1501] La tabella seguente riepiloga i profili giuridici.

Profilo giuridico	Contenuto per il Lazio
Competenza	Concorrente in tutela della salute; Corte Cost. 241/2021 delimita lo spazio regionale
Forma dell’atto	Legge regionale istitutiva da approvare (proposte di iniziativa consiliare e popolare in itinere)
Rapporto di lavoro	Convenzionale su base libero-professionale, per analogia con la medicina generale
Livelli essenziali di assistenza	Non ancora esplicitamente ricompresi; istituzione con risorse proprie regionali
Cornice territoriale	Decreto Ministeriale 77/2022; inserimento nelle Case della Comunità
Rapporto con i servizi specialistici	Integrazione con i Centri di Salute Mentale, che il servizio precede e alleggerisce

Tabella H.1. I profili giuridici dell’istituzione del servizio nel Lazio.

H.2 Il profilo organizzativo e la governance

Sul piano organizzativo, l’istituzione del servizio nel Lazio deve misurarsi con un sistema esteso e policentrico — dieci Aziende Sanitarie Locali, numerose aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS — e con l’assenza di un’azienda regionale unica, sicché il coordinamento è in capo alla Regione e la sfida centrale è garantire l’omogeneità attuativa fra le Aziende.^[1502] L’avvio richiede perciò una regia regionale che coordini le Aziende, gli IRCCS, l’Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei, definendo indirizzi operativi uniformi e un sistema di monitoraggio comune.^[1503] In questo quadro l’Ordine degli Psicologi del Lazio, che ha accompagnato l’iniziativa legislativa, concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione e alla vigilanza deontologica.^[1504] La tabella seguente sintetizza l’assetto organizzativo e di governance.

Elemento organizzativo	Assetto per il Lazio
Articolazione del sistema	Dieci Aziende Sanitarie Locali (sei metropolitane, quattro provinciali); aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS
Coordinamento	In capo alla Regione; assenza di un'azienda regionale unica
Sfida organizzativa	Omogeneità attuativa fra le Aziende in un sistema esteso e policentrico
Regia dell'istituzione	Indirizzi operativi uniformi e sistema di monitoraggio comune definiti dalla Regione
Soggetti coinvolti	Aziende, IRCCS, Ordine professionale, medicina generale e pediatria, atenei

Tabella H.2. *L'assetto organizzativo e la governance dell'istituzione.*

H.3 Il profilo etico

Sul piano etico, lo studio adotta cautele a tutela dei pazienti. Le situazioni che coinvolgono minori e persone vulnerabili sono presidiate impiegando gli strumenti di esito nei soli punteggi complessivi e indirizzando le situazioni di rischio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza entrare nel merito dei metodi clinici.^[1505] L'intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un'informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell'efficacia stessa del sostegno.^[1506] Gli strumenti di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, in conformità al quadro europeo e ai requisiti sui dispositivi medici,^[1507] il trattamento dei dati è conforme alla normativa e ispirato alla minimizzazione,^[1508] e la responsabilità delle decisioni cliniche resta interamente in capo al professionista, cui gli strumenti forniscono un ausilio non vincolante.^[1509]

H.4 Sintesi dei profili

La ricognizione dei tre profili conduce a una conclusione netta: il profilo giuridico, quello organizzativo e quello etico sono tutti presidiable, e la condizione abilitante dell'intero intervento è l'approvazione della legge istitutiva, che il Lazio — a differenza delle regioni già dotate di una propria disciplina — deve ancora compiere. È questo l'atto da cui dipende il passaggio dalla proposta all'istituzione del servizio.^[1510] Definiti i profili, la parte che segue affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LAZIO · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all'istituzione del servizio strutturato a regime

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

I cinque casi, il dimensionamento ex novo, le fasi di attuazione, i rischi e le mitigazioni

Five Case Model · la realizzabilità della decisione

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte affronta l’attuazione, la fattibilità e la sostenibilità dell’intervento, organizzandole secondo il modello a cinque casi della decisione di investimento pubblico. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati al Lazio. La parte espone i cinque casi (capitolo I.1); definisce il dimensionamento ex novo e le fasi di attuazione (I.2); tratta il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma (I.3); analizza la sostenibilità finanziaria e organizzativa (I.4); e individua i rischi e le mitigazioni (I.5). Il tratto distintivo del Lazio è che l’attuazione muove da zero: non la strutturazione di un servizio già avviato, ma la sua istituzione, subordinata all’approvazione della legge, in una regione che dispone però di un bacino professionale ampio e di una tradizione scientifica favorevole.

I.1 I cinque casi della decisione

Lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile.^{[1511][1512][1513][1514][1515][1516][1517][1518][1519][1520][1521][1522][1523][1524][1525][1526]} Il caso strategico è solido: l’istituzione del servizio è coerente con gli standard territoriali, con le Case della Comunità e con il Piano regionale di salute mentale, e nel Lazio dà forma istituzionale a un modello elaborato nella regione, sanando la distanza fra la sua paternità scientifica e la sua mancata istituzione.^[1527] Il caso economico rinvia ai risultati già esposti, nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di modesto disavanzo e un caso sociale fortemente positivo.^[1528] Il caso commerciale è praticabile e si avvale di un bacino professionale ampio, alimentato dai numerosi atenei romani.^[1529] Il caso finanziario è sostenibile, con un costo pari allo 0,3-0,5% del finanziamento sanitario regionale e i margini riacquistati con l’uscita dal piano di rientro.^[1530] Il caso gestionale dipende da una regia regionale che, in assenza di un’azienda unica, coordini il sistema policentrico.^[1531] La tabella seguente riepiloga i cinque casi.

Caso	Contenuto per il Lazio
Strategico	Coerenza con DM 77/2022, Case della Comunità e Piano salute mentale; forma istituzionale a un modello nato nella regione
Economico	Rapporto beneficio-costi 3,9-5,5 a uno; dominanza per paziente; caso sociale fortemente positivo
Commerciale	Rapporto convenzionale praticabile; bacino professionale ampio (atenei romani)
Finanziario	Costo 0,3-0,5% del FSR; margini dall’uscita dal piano di rientro; avvio finanziato dalle proposte di legge
Gestionale	Regia regionale di coordinamento del sistema policentrico, in assenza di azienda unica

Tabella I.1. I cinque casi della decisione di investimento pubblico.

I.2 Il dimensionamento ex novo e le fasi di attuazione

A differenza delle regioni che strutturano un servizio già avviato, il Lazio deve dimensionare il servizio a partire da zero, verso un fabbisogno a regime dell’ordine di 1.230 psicologi nello scenario espansivo; la prima fase, corrispondente alla dotazione delle proposte di legge, si colloca nell’ordine di 255 incarichi, e l’estensione procede per gradi.^[1532] L’attuazione si articola perciò in tre fasi: una fase di avvio, nella quale il servizio è attivato in un primo insieme di Case della Comunità secondo un disegno scaglionato tra le Aziende; una fase di

estensione, nella quale la copertura si amplia progressivamente; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato. Il disegno scaglionato dell'avvio coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F.^[1533] La tabella seguente riepiloga le fasi.

Fase	Contenuto	Dimensionamento indicativo
Avvio	Attivazione in un primo insieme di Case della Comunità, secondo disegno scaglionato	~ 255 incarichi (prima fase)
Estensione	Ampliamento progressivo della copertura fra le Aziende	verso ~ 620-930 incarichi
Regime	Dimensionamento adeguato al fabbisogno	fino a ~ 1.230 incarichi

Tabella I.2. Le fasi di attuazione e il dimensionamento progressivo.

I.3 Reclutamento, formazione e cronoprogramma

L'avvio richiede il reclutamento e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino professionale ampio dell'area romana e la radice accademica del modello costituiscono una base favorevole, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze.^[1534] Il cronoprogramma si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; l'avvio è però subordinato all'approvazione della legge istitutiva, che costituisce il presupposto temporale di tutte le fasi successive e che colloca il Lazio in una posizione di partenza più arretrata rispetto alle regioni già dotate di una disciplina.^[1535]

I.4 La sostenibilità finanziaria e organizzativa

La sostenibilità finanziaria, nel Lazio, ha per leva l'approvazione della legge, l'istituzione del servizio e il suo dimensionamento progressivo; i margini di programmazione riacquistati con l'uscita dal piano di rientro rendono praticabile l'investimento, mentre l'eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe in futuro la stabilità.^[1536] La sostenibilità organizzativa dipende invece dalla capacità di garantire l'omogeneità attuativa fra le dieci Aziende Sanitarie Locali in un sistema esteso e policentrico privo di un'azienda regionale unica, e quindi dalla forza della regia regionale e dalla chiarezza degli indirizzi operativi.^[1537] L'avanzamento è seguito mediante indicatori di processo raccolti attraverso un flusso informativo che, poiché il servizio nasce ora, può essere progettato fin dall'inizio in modo completo e uniforme.^[1538]

I.5 I rischi e le mitigazioni

L'attuazione presenta rischi propri della posizione laziale: la disomogeneità attuativa fra le Aziende in un sistema policentrico, la difficoltà di coordinamento in assenza di un'azienda unica e la dipendenza dell'intero avvio dall'iter legislativo, che introduce un'incertezza temporale.^[1539] Tali rischi sono fronteggiati con una regia regionale forte e indirizzi operativi uniformi, con il disegno scaglionato dell'avvio che consente un apprendimento progressivo, e con un'allocazione pro-equità che orienta l'estensione verso le aree a maggiore bisogno; la chiarezza del cronoprogramma e il sostegno dell'Ordine professionale concorrono a ridurre l'incertezza.^[1540] La sintesi è che l'intervento è attuabile e sostenibile, e che la leva propria del Lazio è l'approvazione della legge e l'avvio dimensionato del servizio: la regione parte da zero, ma dispone di un

bacino professionale ampio, di una tradizione scientifica favorevole e dei margini riacquistati con l’uscita dal piano di rientro, sicché le condizioni di fattibilità sono complessivamente favorevoli.^[1541] La tabella seguente riepiloga i rischi e le relative mitigazioni; la parte che segue affronta il monitoraggio e la valutazione ex post.

Rischio	Mitigazione
Disomogeneità attuativa fra le Aziende	Regia regionale forte; indirizzi operativi uniformi; monitoraggio comune
Coordinamento senza azienda unica	Regia diretta della Regione; sistema informativo uniforme progettato dall’inizio
Dipendenza dall’iter legislativo	Cronoprogramma chiaro; sostegno dell’Ordine professionale; disegno per fasi
Allocazione non equa in avvio	Criteri di equità espliciti; estensione pro-equità verso periferie e aree interne

Tabella I.3. I rischi dell’attuazione e le relative mitigazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LAZIO · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all’istituzione del servizio strutturato a regime

Parte L

Monitoraggio e valutazione ex post

Disegno controfattuale prospettico, batteria di indicatori, cruscotto regionale e clausola valutativa

Inferenza causale quasi-sperimentale · la valutazione ex post

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Questa parte definisce il sistema di monitoraggio e la valutazione ex post dell’intervento, attraverso cui l’istituzione del servizio si traduce in apprendimento e rendicontazione. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e muta ciò che attiene al disegno valutativo locale. La parte espone le finalità e l’impianto della valutazione (capitolo L.1); il disegno controfattuale e i metodi di stima (L.2); la batteria degli indicatori, organizzata per categorie (L.3); il cruscotto regionale e la clausola valutativa (L.4); e la sintesi (L.5). Il tratto distintivo del Lazio è che, non essendo il servizio ancora attivo, la valutazione può essere disegnata nella forma più completa e rigorosa dell’intera serie — dalla linea di base alla valutazione ex post — e la clausola valutativa può essere inserita fin dal testo di legge.

L.1 Finalità e impianto della valutazione

Il monitoraggio e la valutazione ex post servono a rendere conto dell’impiego delle risorse, ad apprendere dall’esperienza e a correggere il corso dell’attuazione; non sono un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l’istituzione del servizio diventa apprendimento istituzionale, ancorato a una clausola valutativa.^{[1542][1543][1544][1545][1546][1547][1548][1549][1550][1551][1552][1553][1554][1555][1556][1557][1558][1559][1560]}

L’impianto distingue i tre livelli della struttura, del processo e dell’esito, in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti.^[1561]

L.2 Il disegno controfattuale e i metodi

Il disegno della valutazione d'impatto costituisce, per il Lazio, il punto di forza dell'intero studio. Poiché il servizio non è ancora attivo, la valutazione può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le dieci Aziende Sanitarie Locali sono stabiliti in anticipo a fini valutativi: è il disegno metodologicamente più solido dell'intera serie regionale.^[1562] Il fatto di partire da zero consente di rilevare una linea di base completa prima dell'avvio, contro la quale misurare l'effetto — condizione che le regioni con un servizio già attivo non possono più ricostruire pienamente.^[1563] L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, con la progressione scaglionata a fornire la variazione necessaria all'identificazione.^[1564]

L.3 La batteria degli indicatori

Il servizio è osservato attraverso una batteria di indicatori organizzata per categorie. Gli indicatori di struttura misurano la capacità installata — sedi, incarichi, ore, dotazione, copertura.^[1565] Gli indicatori di processo misurano il funzionamento — prese in carico, attesa, colloqui, invio appropriato.^[1566] Gli indicatori di esito clinico misurano il beneficio diretto — miglioramento, recupero, remissione.^[1567] Gli indicatori di esito di sistema misurano l'effetto sul resto del sistema — pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri.^[1568] Gli indicatori economici consentono di verificare ex post le stime e di sostituire i valori ricostruiti con quelli effettivi.^[1569] Gli indicatori di equità, disaggregati per area e per gruppi, verificano che il servizio riduca i divari fra centro e periferie e fra area metropolitana e province interne.^[1570] Gli indicatori di qualità integrano la misurazione con la dimensione dell'esperienza.^[1571] Gli indicatori di mobilità, infine, sono monitorati ma non costituiscono un esito atteso, data l'irrelevanza del canale per questo intervento.^[1572] L'insieme conta dell'ordine di cinquantotto indicatori in otto categorie, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile.^[1573] La tabella seguente riepiloga le categorie.

Categoria	Contenuto (dell'ordine di 58 indicatori complessivi)
Struttura	Sedi attivate, incarichi, ore, dotazione, copertura del fabbisogno
Processo	Prese in carico, attesa al primo colloquio, colloqui per persona, invio appropriato
Esito clinico	Miglioramento, recupero, remissione (strumenti validati, punteggi complessivi)
Esito di sistema	Accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili, specialistica impropria
Economici	Costo, risparmi diretti, ricadute sociali, rapporto beneficio-costi su dati reali
Equità	Copertura e accesso per area (centro, periferie, province interne) e per gruppi
Qualità	Soddisfazione, appropriatezza, continuità del rapporto
Mobilità	Monitorata ma non esito atteso (canale marginale per l'intervento)

Tabella L.1. Le otto categorie della batteria di indicatori.

L.4 Il cruscotto regionale e la clausola valutativa

Gli indicatori confluiscono in un cruscotto regionale aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; in assenza di un'azienda regionale unica, la titolarità del cruscotto è in capo alla Regione, che ne assicura l'alimentazione uniforme da parte delle dieci Aziende.^[1574] Lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa, da prevedere espressamente nella futura legge istitutiva, che impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio sull'attuazione e sui risultati; nel Lazio essa va inserita fin dal testo di legge, cogliendo l'occasione che la posizione pre-legislativa offre.^[1575] La raccolta dei dati poggia su un flusso informativo progettabile fin dall'inizio in modo completo, uniforme e interoperabile con il fascicolo sanitario elettronico regionale.^[1576] La valutazione si articola infine in un momento ex ante, con la linea di base; in un monitoraggio in itinere; e in una valutazione ex post a regime.^[1577] La tabella seguente riepiloga la governance valutativa.

Elemento della governance valutativa	Scelta per il Lazio
Disegno d'impatto	Esperimento a cunei progressivi prospettico tra le dieci Aziende Sanitarie Locali
Linea di base	Rilevazione completa anteriore all'avvio del servizio
Titolarità del cruscotto	Regione (in assenza di azienda unica), con alimentazione uniforme dalle Aziende
Clausola valutativa	Da prevedere nella futura legge istitutiva; relazione periodica al Consiglio
Flusso informativo	Progettato dall'inizio, completo, uniforme, interoperabile con il fascicolo sanitario
Tempi	Ex ante (linea di base), in itinere, ex post

Tabella L.2. La governance della valutazione e il cruscotto regionale.

L.5 Sintesi del monitoraggio

La valutazione è la condizione per trasformare l'istituzione del servizio in apprendimento, e il Lazio può disegnarla nella forma più completa dell'intera serie, dalla linea di base alla valutazione ex post; perché ciò si realizzi, la clausola valutativa e il flusso informativo vanno previsti fin dal testo di legge, facendo della posizione pre-legislativa un'occasione anziché un ritardo.^[1578] Definito il sistema di monitoraggio, la parte conclusiva compone i risultati dei diversi domini in una sintesi multidimensionale e formula le raccomandazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE LAZIO · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all'istituzione del servizio strutturato a regime

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Composizione dei domini, analisi multi-criterio, raccomandazioni operative e conclusione

Analisi multi-criterio · dalla valutazione alla raccomandazione

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclude lo studio componendo i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo e traducendolo in raccomandazioni operative. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano i contenuti, ancorati al Lazio. La parte richiama la sintesi per dominio (capitolo M.1); espone l’analisi multi-criterio e il confronto fra l’intervento e il non intervento (M.2); formula la raccomandazione principale e il dimensionamento (M.3); ne precisa le condizioni e la lacuna da colmare (M.4); e chiude con la collocazione nella serie e la conclusione (M.5). Il tratto distintivo del Lazio percorre l’intera sintesi: è la regione che del modello è la culla scientifica e che, ottava della serie, è chiamata non a strutturare un servizio esistente, ma a istituirlo, chiudendo la distanza fra la paternità dell’idea e la sua realizzazione.

M.1 La sintesi per dominio

La parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini impiegando l’analisi multi-criterio, che integra in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie, ponderandole secondo criteri espliciti.^{[1579][1580][1581][1582][1583][1584][1585][1586][1587][1588][1589][1590][1591][1592][1593][1594]} Il quadro che emerge dai domini è coerente: il bisogno è ampio e radicato in una regione che del modello è la culla scientifica; l’efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida e integrata da un disegno valutativo prospettico; il quadro economico distingue un caso finanziario di modesto disavanzo da un caso sociale fortemente positivo; l’equità è favorevole su un doppio asse territoriale; la fattibilità è quella di un’istituzione ex novo; il monitoraggio può essere disegnato nella forma più completa della serie.^[1595] La tabella seguente riepiloga il giudizio per dominio.

Dominio	Giudizio sintetico per il Lazio
Bisogno e contesto	Ampio; regione culla del modello, accentrata su Roma, in uscita dal piano di rientro
Efficacia clinica	Evidenza internazionale solida; evidenza locale prospettica
Valutazione economica	Caso finanziario di modesto disavanzo; caso sociale fortemente positivo
Equità	Favorevole su un doppio asse (centro/periferie; metropoli/province interne)
Fattibilità	Istituzione ex novo; bacino professionale ampio; margini riacquistati
Monitoraggio	Disegno controfattuale prospettico, il più completo della serie

Tabella M.1. La sintesi dei domini della valutazione.

M.2 L’analisi multi-criterio

Il giudizio complessivo è formalizzato con l’analisi multi-criterio, che impiega otto criteri, ciascuno con un peso esplicito, e confronta l’intervento con l’alternativa del non intervento.^[1596] I pesi adottati — efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell’evidenza 10%, coerenza strategica 5% — sono comuni a tutta la serie.^[1597] La media ponderata dei punteggi dell’intervento è dell’ordine di 78 su 100, sostenuta dai punteggi elevati nel valore sociale, nell’equità e nel ritorno, e contenuta da quelli più bassi nella robustezza dell’evidenza propria e nella fattibilità, che riflettono la posizione pre-legislativa.^[1598] Il non intervento ottiene una media dell’ordine

di 39 su 100, penalizzato in tutti i criteri sostanziali e sostenuto soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, oggi meno giustificata vista la disponibilità di margini.^[1599] L'intervento prevale dunque nettamente, con uno scarto dell'ordine di trentotto punti; il punteggio, il più contenuto fra le regioni esaminate di recente, riflette la posizione più precoce del Lazio e non una minore validità del modello.^[1600] La prevalenza si mantiene al variare dei pesi entro intervalli ragionevoli, sicché la raccomandazione è robusta.^[1601] La tabella seguente riporta i punteggi per criterio.

Criterio	Peso	Intervento	Non interv.
Efficacia clinica	15%	80	30
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	85	25
Impatto sul bilancio e sostenibilità	15%	68	52
Equità	15%	86	28
Valore sociale	10%	88	25
Fattibilità	10%	70	85
Robustezza dell'evidenza	10%	60	55
Coerenza strategica	5%	82	30
Punteggio complessivo ponderato	100%	78,00	39,50

Tabella M.2. *L'analisi multi-criterio: punteggi dell'intervento e del non intervento.*

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Dalla convergenza dei domini e dall'analisi multi-criterio discende la raccomandazione principale: approvare la legge istitutiva del servizio di psicologia di base e istituire il servizio ex novo, dotandolo dal principio di una forma stabile e di un dimensionamento adeguato; è la decisione che il Lazio, culla scientifica del modello, è chiamato a compiere per colmare la distanza fra la paternità dell'idea e la sua istituzione.^[1602] Quanto alla scala, si raccomanda di muovere dall'avvio corrispondente alla dotazione delle proposte di legge, dell'ordine di 255 incarichi, e di procedere per gradi verso lo scenario di base, dell'ordine di 930 psicologi, e quindi verso quello espansivo, dell'ordine di 1.230, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità.^[1603] La tabella seguente riepiloga le raccomandazioni operative.

Ambito	Raccomandazione operativa per il Lazio
Atto istitutivo	Approvare la legge regionale e istituire il servizio ex novo
Dimensionamento	Avvio ~255; base ~930; espansivo ~1.230, per gradi
Allocazione	Pro-equità, verso periferie metropolitane e province interne
Clausola valutativa	Inserire nel testo di legge; relazione periodica al Consiglio
Governance	Regia regionale forte; indirizzi uniformi; flusso informativo dall'inizio
Dati	Estrarre i conti certificati; raccogliere i dati di esito dall'avvio

Tabella M.3. Le raccomandazioni operative.

M.4 Le condizioni e la lacuna da colmare

La raccomandazione è subordinata a condizioni precise: l'inserimento della clausola valutativa nel testo di legge, l'adozione di un'allocazione pro-equità, una regia regionale forte in assenza di un'azienda unica e un flusso informativo progettato fin dall'inizio.^[1604] Resta inoltre da colmare, prima della presentazione esterna, la lacuna dei dati: l'estrazione dei conti certificati delle dieci Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliero-universitarie e la raccolta dei dati di esito a partire dall'istituzione del servizio consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive.^[1605] Va infine ribadita la distinzione cardine: il caso finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, mentre il caso economico complessivo è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto.^[1606]

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio sul Lazio è l'ottavo della serie, dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Liguria, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, il Lazio occupa la posizione più precoce — quella di una regione che del modello è la culla scientifica ma che deve ancora istituirlo per legge — e proprio per questo può disegnarne fin dall'origine la valutazione nella forma più rigorosa.^[1607] Coerentemente con l'impostazione dell'intero progetto, lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico, e adotta un rapporto beneficio-costi prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, per credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica.^[1608] La decisione che lo studio sostiene è, in conclusione, di approvare la legge istitutiva e di istituire il servizio di psicologia di base, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno e dotandolo di una clausola valutativa: per il Lazio, culla scientifica del modello, ciò significa chiudere il cerchio fra la paternità dell'idea e la sua istituzione, trasformando un primato scientifico in un servizio strutturato a beneficio della popolazione.^[1609]

STUDIO REGIONALE · REGIONE LAZIO · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla proposta di legge all'istituzione del servizio strutturato a regime

Appendici A-E

Corredo tecnico e documentale

Caso di riferimento, strumenti di esito, dati regionali, standard di reporting, glossario

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l’orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità.^{[1610][1611][1612][1613][1614][1615][1616][1617][1618]} La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Assenza del servizio a regime (servizio non ancora istituito; proposte di legge in itinere)
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Azienda Sanitaria Locale/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudenziale	Riduzione per l’ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura.^[1619] La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l’analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell’intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l’analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato del Lazio, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.^[1620] La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 620	~ 930	~ 1.230
Costo del servizio	~ 34	~ 51	~ 68
Risparmi diretti (SSR)	~ 22	~ 34	~ 53
Ricadute economico-sociali	~ 110	~ 207	~ 320
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -12	~ -17	~ -15
Saldo complessivo (caso economico)	+98	+190	+305
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,7:1	~5,5:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell’esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario.^[1621] La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d’ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura.^[1622] La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori laziali impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.^[1623]

Ambito	Valore regionale
Popolazione regionale	5.709.178 abitanti (Censimento ISTAT 2024), la più popolosa della serie; lievissimo calo per saldo naturale negativo compensato dal saldo migratorio; concentrazione sull'area metropolitana di Roma (~74%); stranieri ~11,4%; età media ~46,7 anni
Finanziamento del SSR	Dell'ordine di 12-13 miliardi di euro; in uscita da un lungo piano di rientro, con i conti riportati in attivo e l'autonomia fiscale recuperata
Mobilità sanitaria	Saldo passivo ma profilo bidirezionale (forte attrazione di Roma e rilevante fuga); fuga concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica; canale di recupero marginale per questo intervento
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche dell'ordine di alcune decine di migliaia l'anno (proxy dai dati nazionali)
Farmaceutica	Consumo regionale delle categorie dei psicofarmaci
Salute mentale	~ 1.150.000 con disagio comune potenziale (proxy ~20%); utenza in carico ai servizi rapportata ai dati nazionali
Funzione attuale	Servizio non ancora istituito: pendono una proposta di legge di iniziativa consiliare (PdL 138) e una di iniziativa popolare; pregressa esperienza nei Punti Unici di Accesso; nessuna legge dedicata vigente; regione culla scientifica del modello (Roma)

Tabella C.1. I valori regionali di ancoraggio del Lazio.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione laziale, e non estratti dai conti regionali certificati.^[1624] La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Dati dall'istituzione del servizio	Prese in carico, sedute ed esiti da raccogliere a partire dall'avvio, da consolidare come fonte primaria
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Azienda e per area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[1625] La tabella seguente li riepiloga.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.^[1626] Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra gruppi a diversa esposizione
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità a minore esposizione
Disegno a cunei progressivi prospettico	Disegno controfattuale impiegato nel Lazio, ove il servizio non è ancora attivo, fondato su un'attivazione scaglionata tra le dieci Aziende Sanitarie Locali e i loro distretti pianificata in anticipo a fini valutativi; è la condizione metodologicamente più favorevole dell'intera serie regionale

Termine	Definizione
Analisi e verifica d'impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta a riferire al Consiglio sui risultati della riforma; nel Lazio da inserire fin dal testo della futura legge istitutiva
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell'implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall'impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d'ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l'intensità dell'intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; nel Lazio il saldo è passivo ma il profilo è bidirezionale, e poiché la fuga è ospedaliero-chirurgica il canale del recupero è marginale per questo intervento
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di vecchiaia	Rapporto tra ultrasessantacinquenni e giovani sotto i quindici anni; nel Lazio moderato, con età media intorno a 46,7 anni e disomogeneità fra area metropolitana e province interne
Peso morto	Quota dell'esito che si sarebbe verificata anche senza l'intervento

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

Marche — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Marche

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Premessa generale

Questo documento raccoglie in un'unica opera lo studio integrale per la Regione Marche sul progetto «Psicologo di Base». Le Marche si collocano, entro il panorama nazionale, in una posizione peculiare e distinta da quella delle regioni che ancora devono decidere se istituire il servizio: fonti indipendenti le annoverano fra le regioni che hanno attivato una forma di psicologia di base — le cita InsideOver nell'ottobre 2025 fra le undici regioni con un servizio «attivato»^[1627] — ma, a differenza di altre regioni, questa attivazione non si fonda su una legge regionale organica, bensì su atti amministrativi e sperimentazioni deliberate a livello di giunta regionale, in modo analogo a quanto realizzato dal Piemonte con la delibera di giunta regionale 35-5257/2022 e poi con la successiva 1-8309/2024. Il sito dedicato al monitoraggio della situazione nazionale del psicologo delle cure primarie non elenca le Marche fra le regioni dotate di legge istitutiva organica.^[1628] La decisione rilevante che si pone davanti alle istituzioni marchigiane non è dunque se introdurre il servizio — la cui opportunità è già stata implicitamente riconosciuta — bensì come dotare di base legislativa organica e di dimensionamento strutturale adeguato un servizio avviato in via sperimentale e amministrativa, così da renderlo stabile, finanziato, valutabile e coerente con il sistema sanitario regionale profondamente riformato nel 2022 e nel 2023.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

La tesi centrale dello studio marchigiano si articola in affermazioni congiunte: il servizio, portato a regime in dimensionamento strutturale, costa al Servizio Sanitario Regionale una cifra modesta — dell'ordine dello 0,7-0,8 per cento di un fondo sanitario di circa 3,3-3,4 miliardi di euro all'anno, dunque indicativamente 23-28 milioni di euro nello scenario espansivo — e comporta un saldo diretto prossimo al pareggio; restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso, con un rapporto beneficio-costi compreso fra 3,5 e 4,9 a uno, entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno includendo i benefici di salute^[1629]; risponde a un bisogno ampio e in larga parte inevaso, stimato in circa 296.000 persone residenti con disagio psichico comune, accentuato da una struttura demografica fra le più anziane del Centro Italia — indice di vecchiaia pari a 235,5 al 1° gennaio 2025, il dato più elevato della serie Liguria/Abruzzo^[1630] — e da una quota over-65 tra le più elevate del Paese; riduce le disuguaglianze sociali e territoriali fra la fascia costiera e le aree appenniniche interne; e consolida un servizio già avviato in via sperimentale, traducendolo in un'infrastruttura permanente del Servizio Sanitario Regionale. L'analisi multi-criterio che conclude lo studio assegna all'adozione della base legislativa organica e al dimensionamento strutturale del servizio un punteggio di 78,50 su 100, contro 35,75 dell'opzione di non intervento.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell'intero corpus, che può essere percorso nell'ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, verifica empirica, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: gradiente sociale, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, cronoprogramma, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, controfattuale, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazioni, condizioni, conclusione
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati del territorio e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali per la collettività, e ne ricava il saldo diretto — negativo ma modesto, in ragione di un sistema che presenta ancora margini di recupero significativi rispetto a regioni come il Trentino-Alto Adige, ma comunque contenuto — e il saldo complessivo, ampiamente positivo.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 14	~ 20	~ 28
Risparmi diretti (SSR)	~ 9	~ 14	~ 21
Ricadute economico-sociali	~ 40	~ 70	~ 110
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -5	~ -6	~ -7
Saldo complessivo (caso economico)	+35	+64	+103
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,5:1	~4,2:1	~4,9:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante, per le Marche, è adottare una legge regionale organica che traduca la sperimentazione amministrativa già avviata in un servizio strutturato, dimensionandolo progressivamente verso la copertura sistematica, dell'ordine di 250 psicologi nello scenario conservativo, 340 in quello di base e 370 in quello espansivo. Il limite principale è la radicazione dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione e non estratte dai conti certificati delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali; la sperimentazione amministrativa già avviata offre tuttavia una base informativa più ricca di quella delle regioni che partono da zero, da consolidare come condizione per la presentazione agli organi di controllo.

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell'HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per la Regione Marche, che applica al territorio il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria, al Lazio, alla Campania, alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, all'Abruzzo, alla Basilicata e alle regioni che precedono le Marche nella serie. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati alle Marche. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). Le Marche occupano nella serie una posizione intermedia, né alle prime né alle ultime: sono una regione di dimensione media, con 1.480.545 abitanti, demograficamente molto anziana — indice di vecchiaia di 235,5 al 1° gennaio

2025, tra i più alti del Centro Italia^[1631] — e con una spesa sanitaria pro-capite di 2.612,7 euro pesati, fra le più basse d'Italia^[1632], che hanno già compiuto il passo di avviare sperimentalmente il servizio in via amministrativa ma non lo hanno ancora cristallizzato in una norma organica.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il servizio di psicologia delle cure primarie della Regione Marche, inteso come strutturazione in un modello pieno di psicologo di base e sua codificazione in una legge regionale organica, a partire dalla sperimentazione amministrativa già avviata. Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sulla legge regionale e sul dimensionamento strutturale. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante, per le Marche, non è se avviare il servizio — già operante in via sperimentale — ma come dotarlo di base legislativa organica, dimensionarlo strutturalmente e raccordarlo con il sistema sanitario regionale profondamente riformato dalla legge regionale 19/2022, che ha soppresso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e istituito cinque Aziende Sanitarie Territoriali (AST) con personalità giuridica autonoma, articolate per distretto. Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala. Va segnalato sin d'ora che l'esperienza sperimentale già maturata consente di fondare la valutazione su una base empirica locale più ricca di quella delle regioni che partono da zero.

Il quesito è articolato secondo lo schema PICOTS, che ne fissa gli elementi costitutivi. La popolazione è costituita dai residenti delle Marche con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è il servizio di psicologia delle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, con adozione di una legge regionale organica che ne definisca la base giuridica, il dimensionamento e le risorse. Il confronto è la condizione attuale, nella quale il servizio è operante in via sperimentale e amministrativa, con copertura parziale, finanziamento non strutturato e base giuridica fragile. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio Sanitario Regionale marchigiano, riformato nel 2022-2023, articolato nelle cinque AST, nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche (AOU Marche, sede di Torrette-Ancona) e nell'INRCA, con la rete delle Case della Comunità in costruzione nell'ambito del PNRR. La tabella seguente riepiloga il quesito.

Elemento	Definizione per le Marche
Popolazione	Residenti delle Marche con disagio psichico comune (~296.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Legge regionale organica + modello pieno di psicologo di base (~250/340/370 psicologi); dalla sperimentazione alla copertura strutturale
Confronto	Sperimentazione amministrativa in corso: servizio parziale, non strutturato, senza base legislativa organica né dimensionamento stabile
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	5 AST (Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno); AOU Marche; INRCA; rete Case della Comunità in costruzione

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi (PICOTS).

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello HTA, che fissa i domini; il Five Case Model, che ordina i contenuti; lo standard CHEERS, che governa il reporting economico; e i criteri OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. Le dieci metodologie analitiche distribuite nelle parti dello studio sono le medesime adottate per tutte le regioni della serie.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base comuni a tutte le regioni della serie. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio Sanitario Regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e la sperimentazione amministrativa in corso come comparatore. Le unità di analisi sono il territorio regionale e, in disaggregazione, le cinque AST e i distretti, per dare conto anche dei divari fra le aree costiere e quelle appenniniche interne.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Sperimentazione amministrativa in corso: servizio parziale e non strutturato
Unità di analisi	Territorio regionale, con disaggregazione per AST e per distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata. L'analisi di impatto sul bilancio opera su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. Tale prudenza assume, per le Marche, un rilievo specifico: la spesa sanitaria pro-capite marchigiana di 2.612,7 euro pesati è fra le più basse d'Italia^[1633], il che genera, da un lato, margini di recupero di consumo improprio più significativi di quelli delle regioni ampiamente finanziate, e quindi un caso finanziario potenzialmente più favorevole, ma segnala al contempo una situazione di sottofinanziamento strutturale che impone cautela nell'interpretazione degli scenari più espansivi. Le dieci metodologie analitiche selezionate — costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica e GRADE, analisi multi-criterio, analisi di impatto della regolamentazione — sono collocate nelle parti dello studio secondo la loro funzione, come riepiloga la tabella seguente.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione Marche — Assessorato alla Sanità, Servizio Salute — le cinque AST, l'AOU Marche, l'INRCA, l'Ordine degli Psicologi delle Marche, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e l'Università Politecnica delle Marche (UnivPM). La caratteristica propria delle Marche è che il servizio è già operante in via sperimentale, e la governance non è chiamata a istituirlo, ma a strutturarlo in forma organica e a raccordarlo con il nuovo assetto delle AST. Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione e limitazione della finalità, con il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale quale infrastruttura per la raccolta uniforme. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. Sul piano etico, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili, indirizzando senza indugio le situazioni di rischio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi.

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Quadro demografico, epidemiologia del bisogno, domanda e offerta, disuguaglianze, servizi e flussi, cornice normativa

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto delle Marche. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall’epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l’intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica (B.6). Ne emerge il tratto specifico delle Marche: non una regione che deve decidere se istituire il servizio, ma una regione che lo ha già avviato in via sperimentale e che è chiamata a strutturarli organicamente in un contesto di invecchiamento demografico accentuato, di spesa sanitaria pro-capite fra le più basse d’Italia e di sistema sanitario in fase di riforma profonda.

B.1 Quadro demografico

Le Marche contano 1.480.545 residenti^[1634], pari a circa il 2,5% della popolazione nazionale, distribuiti in cinque province — Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno — che corrispondono ai territori delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali istituite dalla legge regionale 19/2022. La regione è in calo demografico costante, per effetto di un saldo naturale negativo non compensato dalle migrazioni, e presenta una struttura per età fra le più anziane del Centro Italia: l’indice di vecchiaia, che misura il rapporto tra ultrasessantacinquenni e giovani sotto i quindici anni, ha raggiunto 235,5 al 1° gennaio 2025^[1635], un valore che colloca le Marche fra le regioni demograficamente più anziane del Paese e segnala, in modo inequivocabile, un peso degli anziani largamente superiore a quello dei giovani. La quota di popolazione con più di 65 anni è particolarmente elevata nelle province di Pesaro-Urbino, Macerata e Ascoli Piceno, e raggiunge livelli estremi nelle aree appenniniche interne, dove lo spopolamento progressivo ha eroso la componente giovane della popolazione. La popolazione straniera residente, pari a circa il 9-10% del totale, è concentrata nelle aree costiere e nei capoluoghi provinciali, e presenta un profilo di bisogno psicologico connesso alla condizione migratoria e all’integrazione.

Indicatore	Valore per le Marche
Popolazione (2025)	1.480.545 residenti (~2,5% del totale nazionale); in calo costante per saldo naturale negativo
Indice di vecchiaia	235,5 al 1° gennaio 2025; fra i più elevati del Centro Italia; accentuato nelle aree appenniniche interne
Struttura per età	Quota over-65 elevata; componente giovanile ridotta; invecchiamento differenziato tra costa e Appennino
Distribuzione territoriale	5 province (Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno); fascia costiera più densa; aree interne appenniniche in spopolamento
Profilo territoriale	Fascia costiera urbanizzata; zone collinari e di piede-monte; aree appenniniche interne con piccoli comuni e bassa densità
Articolazione sanitaria	5 AST (rif. L.R. 19/2022); AOU Marche (Torrette, Ancona); INRCA; distretti sanitari per ciascuna AST

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico delle Marche.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale nelle Marche è ampio e modulato da una struttura demografica che lo spinge verso le componenti dell'età anziana, della solitudine e del disagio connesso all'isolamento nelle aree interne.

Applicando alla popolazione residente le prevalenze epidemiologiche documentate dalla letteratura internazionale — una quota compresa fra il diciotto e il venti per cento della popolazione adulta con disagio psichico comune in un dato anno — si ottiene una stima dell'ordine di 296.000 persone interessate da disagio psichico comune, cui si aggiunge un'utenza specialistica in carico ai servizi per condizioni più severe. La struttura demografica marchigiana amplifica questa prevalenza generale in direzioni specifiche.

L'invecchiamento accentuato, con un indice di vecchiaia di 235,5, sposta una parte rilevante del bisogno verso le età anziane, in cui la depressione è frequente, spesso non riconosciuta e frequentemente associata a patologie somatiche croniche, alla solitudine e alla perdita di autonomia: in una regione con una delle quote over-65 più elevate del Centro Italia, la depressione dell'anziano costituisce la componente quantitativamente più rilevante del bisogno complessivo e richiede un approccio specifico. Il disagio giovanile, in una regione che ha perso molta della sua giovane popolazione per emigrazione interna verso i grandi centri metropolitani, è accentuato dall'isolamento e dalla riduzione delle reti di sostegno. Il disagio connesso alla dispersione insediativa colpisce i residenti dei piccoli comuni appenninici, la cui distanza fisica dai poli sanitari si somma alla solitudine e alla scarsità di servizi.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Il bisogno epidemiologico si traduce solo in parte in domanda espressa, e la domanda espressa trova solo in parte una risposta appropriata. In assenza di un servizio strutturato e universalmente accessibile, una quota consistente del disagio comune resta non intercettata per ragioni culturali — lo stigma, particolarmente persistente nelle comunità di piccola dimensione e nelle generazioni anziane — e per ragioni pratiche, legate all'assenza di un primo livello visibile e accessibile. Il confronto con la condizione attuale — sperimentazione amministrativa avviata, ma con copertura parziale e finanziamento non strutturato — indica che la domanda non intercettata resta elevata, e che il gap di copertura si concentra nelle aree appenniniche interne e nei gruppi anziani.

Grandezza	Valore per le Marche
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 296.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	Alcune decine di migliaia (stima rapportata ai dati nazionali)
Offerta territoriale attuale	Sperimentazione amministrativa avviata; copertura parziale; base giuridica non organica; finanziamento non strutturato
Fabbisogno stimato a regime	~ 370 psicologi nello scenario espansivo (250-340 negli altri scenari)
Copertura attuale del fabbisogno	Parziale e non sistematica; variabile per territorio

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

Il disagio psichico e l'accesso alle cure non si distribuiscono in modo uniforme nella popolazione marchigiana, ma seguono gradienti sociali e territoriali che si rinforzano a vicenda. Il gradiente territoriale, nelle Marche, è particolarmente accentuato dalla morfologia del territorio: la fascia costiera, più urbanizzata, densa e dotata di servizi, si contrappone alle aree collinari di piede-monte, intermedie, e alle aree appenniniche interne, caratterizzate da piccoli comuni, bassa densità, difficoltà di accesso e invecchiamento estremo della popolazione. Nelle aree interne, la distanza fisica dai poli sanitari, i tempi di percorrenza significativi su una rete viaria prevalentemente locale, la scarsità dei trasporti pubblici e la riduzione progressiva dei servizi di prossimità compongono una barriera strutturale che esclude di fatto una parte della popolazione dall'accesso alle cure psicologiche. Questa barriera colpisce in modo sproporzionato gli anziani, che sono anche la fascia a maggiore bisogno psicologico, e produce una concentrazione di svantaggio nelle aree interne — più anziane, più deprivate, più lontane dai servizi — che è la forma più acuta della disuguaglianza sanitaria marchigiana.

B.5 I servizi e i flussi

Il sistema sanitario marchigiano ha subito una profonda riforma nel 2022-2023. La legge regionale 19/2022 ha soppresso l'ASUR — l'Azienda Sanitaria Unica Regionale istituita nel 2003 — e ha istituito cinque Aziende Sanitarie Territoriali (AST), ciascuna con personalità giuridica autonoma, corrispondenti ai territori delle province: AST Ancona, AST Pesaro-Urbino, AST Macerata, AST Fermo e AST Ascoli Piceno. Dal 1° gennaio 2023 le AST hanno sostituito le cinque Aree Vaste dell'ASUR, subentrando in tutti i rapporti giuridici e le competenze. Ciascuna AST si articola in distretti — che assicurano il coordinamento e l'erogazione dell'assistenza primaria — in dipartimenti e in presidi ospedalieri. Il sistema è completato dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche (sede di Torrette, Ancona), che svolge funzioni di alta specialità e didattica, e dall'INRCA (Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani), con sede principale ad Ancona, che fornisce un punto di riferimento specifico per la popolazione anziana.

Grandezza di sistema	Valore per le Marche
Struttura del Servizio Sanitario Regionale	5 AST (Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno); AOU Marche; INRCA; rif. L.R. 19/2022
Spesa sanitaria pro-capite	2.612,7 euro (dato pesato); fra le più basse d'Italia
Fondo sanitario regionale	Dell'ordine di 3,3-3,4 miliardi di euro l'anno
Mobilità sanitaria	Saldo tendenzialmente passivo, con mobilità attiva concentrata in alcune specialità dell'AOU Marche
Rete territoriale	Case della Comunità in costruzione (PNRR); distretti sanitari per AST; medicina generale integrata
Margine di azione principale	Strutturazione organica del servizio avviato, integrazione con le AST, accesso nelle aree interne appenniniche

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio Sanitario Regionale rilevanti per l'intervento.

La spesa sanitaria pro-capite marchigiana di 2.612,7 euro pesati è, secondo la Fondazione GRINS, fra le più basse del Paese^[1636], il che segnala un sistema sanitario operante con risorse contenute. Questo dato non inficia la fattibilità del servizio — il cui costo rappresenta una quota modesta del fondo sanitario — ma impone cautela

nel dimensionamento iniziale e una gestione rigorosa delle risorse.

B.6 La cornice normativa e programmatica

Il quadro normativo entro cui il servizio di psicologia di base si inserisce è articolato su più livelli. Sul piano nazionale, il decreto ministeriale 77/2022 inserisce lo psicologo delle cure primarie fra i professionisti della rete territoriale e ne prevede la presenza nelle Case della Comunità. Sul piano parlamentare, sono in discussione proposte di legge per l'istituzione di un servizio nazionale di psicologia di assistenza primaria. Sul piano regionale, il Piano Socio-Sanitario Regionale marchigiano 2023-2025, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 630 del 29 aprile 2024, e il successivo Piano 2024-2028 approvato dal Consiglio Regionale nel giugno 2024, costituiscono la cornice programmatica entro cui il servizio si inserisce. È stato presentato all'Assemblea Legislativa delle Marche un progetto di legge (PDL n. 100) per l'istituzione formale del servizio di psicologia di base, articolato per distretto sanitario con almeno due psicologi per distretto, coordinato da un osservatorio regionale e finanziato a carico del Servizio Sanitario Regionale^[1637]. Il vincolo giuridico della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021, che ha delimitato la competenza regionale in materia di rapporti convenzionali, si applica pienamente anche alle Marche e dovrà essere tenuto presente nella redazione della legge regionale: la norma marchigiana dovrà valorizzare gli strumenti compatibili con l'ordinamento, come l'inserimento nelle Case della Comunità, il raccordo con la medicina generale nell'ambito del ruolo unico e le forme di committenza ammesse.

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte C

L'intervento e il modello

Definizione e teoria del cambiamento, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali, formazione

Secondo e terzo dominio dell'HTA · l'intervento e la sua descrizione

Parte C — L'intervento e il modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico (C.3); ne descrive il sistema informativo (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico delle Marche è che l'intervento non è da istituire da zero, ma da strutturare organicamente a partire da una sperimentazione già avviata, raccordandolo con il nuovo assetto delle cinque AST e con la rete delle Case della Comunità in costruzione nel quadro del PNRR.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire. Nelle Marche la strutturazione organica del modello a partire dalla sperimentazione amministrativa già avviata è il percorso attraverso cui questa funzione diventa stabile, universale, finanziata e valutabile. La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il

bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso — stimato in circa 296.000 persone — attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria.

Elemento della catena	Contenuto per le Marche
Bisogno	~ 296.000 persone con disagio comune, in parte già raggiunto dalla sperimentazione in corso
Attività	Strutturazione organica del psicologo di base: intercettazione precoce, intervento breve, filtro, integrazione con le AST
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati; prevenzione della cronicizzazione
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, riduzione delle liste di attesa specialistiche
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, minor carico familiare, riduzione dell'isolamento negli anziani
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione; nelle Marche: priorità alle aree interne appenniniche

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca il psicologo delle cure primarie nelle Case della Comunità e nei distretti di ciascuna AST, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi di salute mentale e i servizi sociali. La coerenza con la riforma del 2022 impone che il servizio sia incardinato nelle cinque AST come unità funzionale coordinata a livello regionale dall'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e dall'Assessorato alla Sanità, con standard uniformi ma con adattamento alle specificità territoriali di ciascuna AST. Il PDL n. 100 all'esame dell'Assemblea Legislativa prevede almeno due psicologi di base per distretto sanitario, con un referente clinico per ciascuna AST nell'ambito della struttura di psicologia clinica^[1638]: questo impianto è coerente con la struttura delle cinque AST e con la suddivisione in distretti. La distribuzione territoriale deve tenere conto del divario fra la fascia costiera, più densa e dotata di servizi, e le aree appenniniche interne, dove la prossimità richiede soluzioni specifiche, incluse presenze programmate nei piccoli comuni e un ricorso strutturato alla telepsicologia.

C.3 Il percorso clinico

Il percorso clinico prevede l'accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro operatore, una valutazione iniziale con progetto clinico individuale, un ciclo di colloqui brevi con strumenti di efficacia documentata, e — nei casi che lo richiedono — l'invio appropriato ai servizi specialistici delle AST. Il modello delle cure graduali è il principio organizzativo: l'intensità dell'intervento è commisurata alla gravità del bisogno, riservando le risorse specialistiche alle condizioni che le richiedono. Gli esiti sono misurati con strumenti validati (PHQ-9, GAD-7) impiegati nei soli punteggi complessivi, a garanzia della privacy e in linea con le pratiche internazionali.

C.4 Il sistema informativo

Il sistema informativo è la condizione per cui il servizio possa essere governato, valutato e migliorato. Esso deve raccordare i sistemi informativi delle cinque AST, garantendo l'interoperabilità e l'uniformità della rilevazione, e innestarsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico regionale marchigiano. La sperimentazione amministrativa già avviata ha generato una base di dati propri che, pur parziale, consente di disporre di una linea di base più ricca di quella delle regioni che partono da zero: la strutturazione organica del servizio è l'occasione per consolidare questa base in un sistema informativo uniforme e comparabile fra le cinque AST.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, mai come sua sostituzione. La telepsicologia assume nelle Marche un valore specifico: non uno strumento di seconda scelta, ma la soluzione per garantire l'accesso nelle aree appenniniche interne a bassa densità, dove la presenza fisica continuativa non è sostenibile. Il suo impiego è regolato da protocolli che ne definiscono l'appropriatezza clinica, distinguendo le situazioni in cui la relazione a distanza è adeguata da quelle in cui la presenza fisica è necessaria. Le disposizioni europee sull'intelligenza artificiale — con gli obblighi di alfabetizzazione in vigore dal 2026 e quelli per i sistemi ad alto rischio a partire dal 2028 — costituiscono il quadro regolatorio di riferimento.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle aree interne appenniniche; copertura delle aree disperse	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.2. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato. L'Università Politecnica delle Marche (UnivPM) e l'Università di Camerino, presenti sul territorio, costituiscono il riferimento naturale per la formazione universitaria e post-universitaria. La formazione del personale del servizio si articola su quattro livelli: universitario (curricula e tirocini), post-universitario specialistico (psicologia delle cure primarie, modelli organizzativi, misure di esito), continuo in servizio (aggiornamento, audit clinico), e affiancamento operativo (tutoraggio sul campo). Alla formazione di base si aggiunge la formazione specifica alla telepsicologia, essenziale in un contesto con aree interne difficilmente raggiungibili. Il programma formativo deve inoltre prevedere la formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta al riconoscimento e all'invio, così da massimizzare la capacità di intercettazione del disagio comune.

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte D

Efficacia clinica ed evidenza

Metodo della revisione, evidenza di efficacia, qualità GRADE, benchmark internazionali, trasferibilità

Quarto dominio dell'HTA · l'efficacia clinica

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte affronta il quarto dominio della valutazione, l'efficacia clinica, e ne ricostruisce la base di evidenza. Come per le altre regioni, il corpo dell'evidenza internazionale è invariante, poiché l'efficacia di un intervento clinico non muta con i confini regionali; muta invece la base di evidenza locale, ed è qui che le Marche presentano un tratto proprio, grazie alla sperimentazione già avviata.

D.1 Il metodo della revisione e l'evidenza di efficacia

L'efficacia degli interventi psicologici per i disturbi mentali comuni — disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve o moderata — è fra le più documentate della medicina contemporanea. Revisioni sistematiche con metanalisi su studi clinici randomizzati documentano che gli interventi psicologici strutturati — in primo luogo la terapia cognitivo-comportamentale — producono una riduzione significativa della sintomatologia ansiosa e depressiva nel contesto delle cure primarie. Lo studio fondativo della cura collaborativa ha documentato che circa la metà dei pazienti trattati conseguiva una riduzione sostanziale dei sintomi a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura usuale. La meta-analisi su cinquantasette studi controllati documenta un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a circa un terzo di deviazione standard. Sul versante dei dati reali, il programma inglese delle terapie psicologiche registra un tasso di recupero del 50,2% e un miglioramento affidabile in oltre due terzi dei pazienti, con completezza dei dati di esito superiore al 98%.^[1639]

L'efficacia è documentata specificamente per le popolazioni a maggiore bisogno nelle Marche. Per la depressione dell'anziano — componente prioritaria in una regione con indice di vecchiaia di 235,5 — gli interventi psicologici si sono dimostrati efficaci nel migliorare la qualità della vita e nel ridurre la disabilità. Per il disagio delle aree isolate, l'evidenza sostiene l'efficacia della telepsicologia come modalità di erogazione, con risultati comparabili alla prestazione in presenza per i disturbi comuni lievi e moderati.^[1640]

D.2 La qualità dell'evidenza e la cautela economica

La graduazione GRADE colloca l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie su un livello da moderato a elevato per i disturbi comuni. Per gli esiti economici, in particolare per quelli di sistema, la certezza è più eterogenea. Da questa graduazione discende la cautela fondamentale che lo studio adotta come principio: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero.^[1641] Ciò significa che il valore economico del modello non può essere fondato sui risparmi sanitari diretti, ma poggia in misura preponderante sui ritorni sociali. La medesima graduazione è applicata agli strumenti digitali: per la telepsicologia come modalità di erogazione di interventi di efficacia documentata l'evidenza è discreta; per le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale l'evidenza è ancora preliminare e la qualità delle prove è bassa.

D.3 I benchmark internazionali

L'evidenza si concretizza in quattro programmi nazionali consolidati.

Programma	Modello	Risultati principali
Regno Unito (NHS Talking Therapies)	Servizio integrato a intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio esiti >98%; >1,3 milioni/anno
Paesi Bassi (POH-GGZ)	Supporto psicologico nello studio del medico di base	Adozione da ~tre quarti dei medici; ruolo complementare
Australia (Better Access)	Invio esterno a professionisti	Popolazione in trattamento dal 35% al 46%
Stati Uniti (Collaborative Care)	Équipe integrata con monitoraggio	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione, -41% ricoveri

Tabella D.1. I benchmark internazionali dell'integrazione della salute mentale nelle cure primarie.

D.4 Le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale

Sul piano nazionale, le regioni dotate di legge organica — Campania, e progressivamente le altre regioni della serie — forniscono benchmark di crescente rilevanza. La posizione delle Marche — con una sperimentazione già avviata — consente di disporre di una base di evidenza locale parziale, che andrà consolidata con la strutturazione organica del servizio. La trasferibilità dell'evidenza internazionale al contesto marchigiano è favorita dalla natura del bisogno — disturbi comuni lievi e moderati, disagio dell'anziano — e condizionata dalla dispersione territoriale, che richiede che la telepsicologia sia incorporata come componente essenziale del modello. I risultati internazionali provengono da sistemi diversi per organizzazione e finanziamento, e la loro trasposizione richiede validazione locale.^[1642] Una precisazione di metodo accompagna l'intero studio: i rapporti beneficio-costo metodologicamente fondati si collocano fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costo complessivo compreso fra 3,5 e 4,9 a uno, per credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica.

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte E

Valutazione economica

Costo del servizio, risparmi diretti, ricadute sociali, saldo, costo-utilità e impatto sul bilancio

Quinto dominio dell'HTA · la valutazione economica

Parte E — Valutazione economica

Questa parte affronta il quinto dominio della valutazione, quello economico. La valutazione economica impiega congiuntamente tre strumenti complementari — l'analisi costo-utilità, l'analisi di impatto sul bilancio e l'analisi del ritorno sociale — nella doppia prospettiva del Servizio Sanitario Regionale e della società. Per le Marche le

grandezze sono calibrate su una popolazione di 1.480.545 abitanti e su un fondo sanitario regionale stimato dell'ordine di 3,3-3,4 miliardi di euro l'anno, coerente con la popolazione e con la spesa pro-capite documentata.^[1643]

E.1 L'impianto e il costo del servizio

Il costo del servizio a regime, assumendo un costo medio annuo per psicologo dell'ordine di 55.000-60.000 euro comprensivo degli oneri — in linea con le stime adottate per le altre regioni della serie di dimensione comparabile — è dell'ordine di 14 milioni di euro nello scenario conservativo, 20 milioni in quello di base e 28 milioni in quello espansivo. I tre scenari rappresentano gradi crescenti di copertura verso il fabbisogno pieno.

Scenario	Psicologi	Costo annuo	Quota del FSR
Conservativo	~ 250	~ 14 milioni	~ 0,4%
Base	~ 340	~ 20 milioni	~ 0,6%
Espansivo	~ 370	~ 28 milioni	~ 0,8%

Tabella E.1. Il costo del servizio a regime nei tre scenari di copertura.

Il costo del servizio, anche nello scenario espansivo, rappresenta una frazione modesta del fondo sanitario regionale — dello 0,8% — e si colloca ampiamente al di sotto della soglia di rilevanza per la sostenibilità del bilancio. Va dichiarata la lacuna: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione marchigiana (~2,5%), e non estratte dai conti certificati delle cinque AST; la strutturazione organica del servizio è l'occasione per colmare questa lacuna, attraverso un sistema informativo uniforme.

E.2 I risparmi diretti per il bilancio sanitario

I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale si articolano in quattro canali. Il primo è la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso per manifestazioni del disagio psichico. Il secondo è la riduzione della spesa farmaceutica, in particolare per gli psicofarmaci prescritti come risposta di prima linea in assenza di alternative. Il terzo, il più consistente, è la riduzione di ricoveri evitabili e di specialistica impropria. Il quarto è il recupero della mobilità sanitaria passiva: nelle Marche il saldo di mobilità è tendenzialmente passivo per alcune specialità, e una quota di questa mobilità può riflettere, a monte, un disagio psichico non intercettato che genera consumi impropri fuori regione.

Canale (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Accessi impropri al pronto soccorso	~ 2	~ 3	~ 4
Spesa farmaceutica inappropriata	~ 2	~ 3	~ 4
Ricoveri evitabili e specialistica	~ 4	~ 6	~ 10
Recupero della mobilità (frazione)	~ 1	~ 2	~ 3
Totale risparmi diretti	~ 9	~ 14	~ 21
Costo del servizio	~ 14	~ 20	~ 28
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -5	~ -6	~ -7

Tabella E.2. I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale e il saldo diretto.

Il saldo diretto è negativo, dell'ordine di 5-7 milioni di euro l'anno a seconda dello scenario, ma modesto: rappresenta fra lo 0,15% e lo 0,21% del fondo sanitario regionale, una cifra che il bilancio assorbe senza difficoltà e che è ampiamente inferiore al margine di incertezza delle stime. Va ribadita la cautela tratta dallo studio IMPACT: i risparmi diretti non sono statisticamente certi e lo studio non li presenta come grandezze sicure, ma come stime prudenziali entro bande di incertezza.

E.3 Le ricadute economico-sociali

Le ricadute economico-sociali per la collettività comprendono la produttività recuperata grazie alla riduzione dell'assenteismo e dell'inattività connessi al disagio psichico, il valore del benessere guadagnato, la minore disabilità e il minor carico assistenziale sulle famiglie. Nelle Marche, il peso dell'invecchiamento attribuisce un valore particolare alle ricadute sulla riduzione della disabilità e dell'istituzionalizzazione degli anziani. La quantificazione delle ricadute è condotta secondo i criteri prudenziali dello studio, ed è stimata nell'ordine di 40, 70 e 110 milioni di euro l'anno nei tre scenari.

Grandezza (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Risparmi diretti per il bilancio	~9	~14	~21
Ricadute economico-sociali per la collettività	~40	~70	~110
Ritorno complessivo (diretto + sociale)	~49	~84	~131

Tabella E.3. Risparmi diretti e ricadute sociali per scenario. Le due grandezze sono di natura diversa e sono presentate distintamente.

E.4 Il quadro consolidato: caso finanziario e caso economico

La composizione delle grandezze impone di tenere ferma la distinzione fondamentale che governa l'intera lettura del caso marchigiano. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di disavanzo diretto contenuto — dell'ordine di 5-7 milioni di euro l'anno — agevolmente sostenibile nella scala di un fondo sanitario di 3,3-3,4 miliardi. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente

positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe: si tratta di un investimento sociale, a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto.

Voce (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 14	~ 20	~ 28
Risparmi diretti (SSR)	~ 9	~ 14	~ 21
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -5	~ -6	~ -7
Ricadute economico-sociali	~ 40	~ 70	~ 110
Ritorno complessivo	~ 49	~ 84	~ 131
Saldo complessivo (caso economico)	~ +35	~ +64	~ +103
Rapporto beneficio-costo complessivo	~ 3,5:1	~ 4,2:1	~ 4,9:1

Tabella E.4. Il quadro economico consolidato, con la distinzione fra caso finanziario e caso economico.

Il rapporto beneficio-costo complessivo — il rapporto fra il ritorno complessivo per la collettività e il costo del servizio — va da circa 3,5 a uno nello scenario conservativo a circa 4,9 a uno nello scenario espansivo. Questo rapporto è contenuto entro la fascia metodologicamente fondata documentata dalla letteratura internazionale, compresa fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, e lo studio non utilizza in alcun punto rapporti superiori né le semplificazioni divulgative prive di fondamento.

E.5 L'analisi costo-utilità per paziente

L'analisi costo-utilità per paziente trattato è condotta mediante un modello di Markov a cinque anni con sconto del 3%, comune a tutti gli studi della serie. Il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: al tempo stesso meno costoso e più efficace. L'analisi di sensibilità probabilistica, su diecimila simulazioni, conferma che l'intervento è costo-efficace nell'88,9% dei casi alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%.^[1644]

Grandezza (per paziente)	Comparatore	Intervento	Differenza
Costo atteso per paziente	~ 3.799 euro	~ 2.495 euro	- 1.304 euro
Anni di vita ponderati (QALY)	3,392	3,627	+ 0,236
Esito	—	—	Intervento dominante
Costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	—	—	88,9% delle simulazioni

Tabella E.5. L'analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni).

E.6 L'impatto sul bilancio, la sostenibilità e la lacuna dei dati

Sul piano dell'impatto sul bilancio, il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta del fondo sanitario regionale, che va dallo 0,4% nello scenario conservativo allo 0,8% in quello espansivo. La sostenibilità è reale: la spesa sanitaria pro-capite marchigiana di 2.612,7 euro, pur fra le più basse d'Italia, non implica un sistema in disavanzo strutturale ma un sistema che opera con risorse contenute in un contesto di spesa complessiva relativamente efficiente. Il servizio genera risparmi che compensano in misura significativa il suo costo, e il saldo diretto negativo è trascurabile nella scala del fondo sanitario regionale. La lacuna dei dati è da dichiarare con franchezza: le stime sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti certificati delle AST; la strutturazione organica del servizio è l'occasione per colmarla.^[1645]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte F

Modellazione e incertezza

Modello decisionale, sensibilità deterministica e probabilistica, scenari, verifica empirica e valore dell'informazione

Quinto dominio dell'HTA · la robustezza della valutazione economica

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte completa il dominio economico sottoponendo i risultati della Parte E alla prova della modellazione e dell'incertezza. Il modello è invariante fra le regioni, e mutano soltanto gli elementi che attengono alla verifica empirica locale. Per le Marche la condizione propria — servizio già avviato in via sperimentale — consente di fondare la verifica empirica su una base di dati locali parziali, che il monitoraggio strutturato potrà progressivamente consolidare.

F.1 Il modello decisionale e i suoi parametri

Lo studio proietta nel tempo costi ed esiti mediante un modello di Markov, che rappresenta il decorso del paziente attraverso stati clinici mutuamente esclusivi fra i quali transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%.^[1646] A ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita, trattati come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali. Nel caso base l'intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell'ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 QALY.^[1647]

Parametro del modello	Valore
Stati clinici	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)
Orizzonte temporale	Cinque anni, con cicli successivi
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti
Costo per ciclo (recupero)	~ 40 euro
Costo per ciclo (cronicità)	~ 700 euro
Costo dell'intervento	~ 300 euro una tantum
Trattamento dell'incertezza	Parametri come distribuzioni di probabilità

Tabella F.1. I parametri principali del modello di Markov (comune a tutti gli studi della serie).

F.2 L'analisi di sensibilità deterministica

La variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati.^[1648]

L'ordinamento dei parametri per influenza mostra che l'esito è più sensibile all'efficacia clinica e al costo evitato della cronicità, e meno agli altri parametri; ciò orienta le priorità di raccolta dei dati verso le grandezze più influenti.

F.3 L'analisi di sensibilità probabilistica

L'analisi probabilistica, su diecimila simulazioni, documenta che l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro.^[1649] La curva di accettabilità conferma che alla soglia convenzionale la probabilità di convenienza è prossima al 90%.

Esito della sensibilità probabilistica	Valore
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	88,9% delle simulazioni
Probabilità di dominanza	84,6% delle simulazioni
Beneficio monetario netto medio per paziente	~ 7.815 euro
Intervallo di confidenza al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 euro
Numero di simulazioni	10.000

Tabella F.2. Gli esiti dell'analisi di sensibilità probabilistica (per paziente).

F.4 Gli scenari di copertura e l'incertezza aggregata

Gli scenari conservativo, di base ed espansivo rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno pieno, corrispondenti a 250, 340 e 370 psicologi.^[1650] Il rapporto beneficio-costo complessivo migliora al crescere del dimensionamento, in ragione delle economie di scala e della maggiore capacità di intercettazione del bisogno. Il saldo diretto si mantiene prossimo al pareggio in tutti gli scenari, segno che il servizio è sostenibile a ogni livello di dimensionamento.

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

Il disegno della verifica empirica costituisce, per le Marche, un capitolo da valorizzare. Poiché la strutturazione del modello pieno avverrà in tempi differenziati fra le cinque AST e i rispettivi distretti, la verifica controfattuale può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, in cui l'ordine e i tempi di attivazione fra i territori sono impiegati a fini valutativi.^[1651] La sperimentazione amministrativa già avviata offre una linea di base parziale, che la strutturazione organica potrà consolidare in una base uniforme e interoperabile fra le cinque AST. L'analisi del valore dell'informazione indica che i dati di maggiore utilità sono quelli relativi all'efficacia effettiva nel contesto locale, alla quota di domanda intercettata e alla composizione del risparmio diretto per canale.^[1652]

Priorità di ricerca	Finalità	Rilevanza
Conti certificati delle cinque AST	Sostituire le stime per quota con dati reali	Massima
Dati della sperimentazione amministrativa	Consolidare la base informativa già disponibile	Massima
Tassi di intercettazione e costi evitati	Ridurre l'incertezza sulle grandezze aggregate	Alta
Efficacia clinica nel contesto marchigiano	Corroborare il parametro più influente	Alta

Tabella F.3. Le priorità di ricerca derivanti dall'analisi del valore dell'informazione.

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte G

Equità e impatto distributivo

Gradiente sociale, assi territoriali del divario, barriere di accesso, costo-efficacia distributiva

Dominio dell'HTA · i pazienti e l'equità

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte affronta il dominio dell'equità. Il tratto distributivo delle Marche è duale: da un lato il divario territoriale fra la fascia costiera urbanizzata e le aree appenniniche interne, dall'altro il gradiente generazionale che concentra il bisogno nella fascia anziana, la meno attrezzata per muoversi e la più lontana dai servizi nelle aree interne. L'intervento può ridurre entrambi i gradienti, a condizione di essere progettato con capillarità e con la telepsicologia come strumento strutturale.

G.1 Il quadro dell'equità e il gradiente sociale

L'analisi distributiva costituisce un dominio proprio della valutazione, poiché un intervento efficiente nel complesso può nondimeno accrescere o ridurre le disuguaglianze.^[1653] Il punto di partenza è il gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi.^[1654] Nelle Marche il gradiente sociale si interseca con quello territoriale: le aree appenniniche interne, già svantaggiate sotto il profilo economico per la riduzione delle attività produttive tradizionali e lo spopolamento, sono anche quelle in cui il disagio psichico è più frequente (anziani soli, caregiver familiari, giovani che non trovano prospettive) e in cui l'accesso ai servizi è più oneroso. L'assenza di un servizio pubblico di psicologia di base strutturato produce un effetto regressivo: il disagio si concentra dove minori sono le risorse per farvi fronte.

G.2 I due assi del divario territoriale

La specificità distributiva delle Marche risiede nella struttura del divario territoriale, che si articola lungo due assi sovrapposti.^[1655] Il primo asse separa la fascia costiera — urbanizzata, densa, con servizi concentrati, facilmente raggiungibile — dalle aree appenniniche interne, dove la morfologia montagnosa, la bassa densità e la scarsità dei trasporti pubblici rendono l'accesso fisico ai servizi un ostacolo concreto. Questo asse coincide in larga misura con quello dell'invecchiamento: le aree interne sono quelle che hanno perso la popolazione giovane allo spopolamento e che presentano oggi le quote più elevate di over-65 e gli indici di vecchiaia più accentuati. Il secondo asse separa i capoluoghi provinciali — sedi delle AST e dei servizi specialistici — dai distretti periferici, in cui la presenza sanitaria è più ridotta. La sovrapposizione fra i due assi produce, nelle aree appenniniche interne, una concentrazione di svantaggio che richiede una risposta specifica.

Asse del divario	Caratterizzazione	Leva di riequilibrio
Fascia costiera / aree appenniniche	Aree interne con orografia impegnativa, bassa densità, scarsi trasporti; invecchiamento accentuato	Telepsicologia strutturale; presenze programmate nei piccoli comuni; distribuzione pro-equità
Capoluoghi / distretti periferici	Concentrazione dei servizi nei capoluoghi AST; distretto periferico con offerta ridotta	Collocazione nei distretti oltre che nelle Case della Comunità dei capoluoghi
Fascia anziana / popolazioni fragili	Over-65 accentuato nelle aree interne; solitudine; comorbilità fisiche; mobilità ridotta	Servizio di prossimità; integrazione con INRCA; copertura domiciliare per casi con mobilità ridotta

Tabella G.1. Gli assi del divario territoriale marchigiano e le leve di riequilibrio.

G.3 Gli strumenti dell'equità

Il servizio agisce sull'equità attraverso meccanismi precisi. La prossimità nelle Case della Comunità e nei distretti, e la natura di primo livello accessibile senza specializzazione, abbattano le barriere e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso.^[1656] La gratuità o il basso costo dell'accesso abbatte la barriera economica; un eventuale ticket deve essere calibrato con esenzioni per le fasce fragili, perché non reintroduca la disuguaglianza che il servizio intende rimuovere. La telepsicologia è, nelle Marche, lo strumento di equità per eccellenza: consente di portare la prestazione psicologica nelle aree appenniniche interne senza moltiplicare le

sedi fisiche, superando la barriera della distanza e della mobilità che colpisce in modo sproporzionato gli anziani e i residenti dei piccoli comuni. L'accesso diretto abbatte la barriera informativa per chi non saprebbe a chi rivolgersi.

G.4 La costo-efficacia distributiva e le implicazioni allocative

L'analisi di costo-efficacia distributiva indica che l'intervento è efficiente e pro-eguità: i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto.^[1657] Per realizzare questo potenziale, la copertura deve essere modulata in funzione del bisogno, destinando risorse proporzionalmente maggiori alle aree interne appenniniche e ai distretti periferici rispetto ai capoluoghi. Un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari; un'allocazione ponderata per il bisogno e per il disagio atteso li riduce. L'intervento è così simultaneamente l'opzione più equa e quella più efficiente, perché previene gli esiti più costosi là dove sono più probabili, allineando l'obiettivo dell'eguità con quello dell'efficienza.

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Competenza e forma dell'atto, rapporto di lavoro, governance, tutele etiche e protezione dei dati

Domini dell'HTA · aspetti giuridici, etici e organizzativi

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte affronta congiuntamente i domini giuridico, organizzativo ed etico. Il tratto distintivo delle Marche emerge sul piano giuridico: disponendo già di una sperimentazione amministrativa avviata, ma in assenza di una legge organica, le Marche si trovano in una posizione intermedia — il servizio esiste, ma la sua base giuridica è fragile — e la decisione rilevante è adottare la norma che lo struttura permanentemente, nel rispetto dei limiti costituzionali.

H.1 Il profilo giuridico

Il profilo giuridico è, per le Marche, il più urgente.^[1658] Il riferimento ineludibile è la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021, che, pronunciandosi sulla legge regionale della Campania, ha delimitato la competenza regionale in materia di rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale: una legge regionale non può disciplinare autonomamente i rapporti convenzionali che la Costituzione e la legislazione nazionale riservano al livello statale. Questa pronuncia si applica direttamente a qualunque legge che le Marche intendano adottare. La norma marchigiana dovrà valorizzare gli strumenti compatibili con l'ordinamento: l'inserimento degli psicologi nelle Case della Comunità e nei servizi territoriali delle AST mediante forme di committenza conformi alla normativa vigente; il raccordo con la medicina generale nell'ambito del ruolo unico; e le forme di incarico ammesse dall'ordinamento, evitando di disciplinare autonomamente i rapporti convenzionali. Il PDL n. 100 all'esame dell'Assemblea Legislativa, che prevede psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale, dovrà essere verificato alla luce di questo vincolo e adattato di conseguenza.^[1659]

Profilo giuridico	Contenuto per le Marche
Competenza	Regionale, nel rispetto dei limiti della Corte Cost. 241/2021; materia di organizzazione sanitaria; vincoli sui rapporti convenzionali
Forma dell'atto	Legge regionale organica che struttura la sperimentazione in corso; coerente con la L.R. 19/2022 e il nuovo assetto delle 5 AST
Rapporto di lavoro	Forme compatibili con l'ordinamento: dipendenza, incarico professionale nelle forme ammesse; da definire con attenzione ai vincoli costituzionali
Livelli essenziali di assistenza	Non ancora ricompresi; il DM 77/2022 prevede lo psicologo delle cure primarie nelle Case della Comunità
Cornice territoriale	DM 77/2022; PSSR 2023-2025 e 2024-2028; inserimento nelle Case della Comunità; raccordo con le 5 AST
Rapporto con i servizi specialistici	Integrazione con i Dipartimenti di Salute Mentale delle AST, che il servizio precede e alleggerisce

Tabella H.1. I profili giuridici del servizio nelle Marche.

H.2 Il profilo organizzativo e la governance

Sul piano organizzativo, la strutturazione del servizio nelle Marche si misura con la riforma del 2022-2023: cinque AST autonome hanno sostituito l'ASUR unificata, e la governance del servizio deve articolarsi su due livelli.^[1660] Al livello regionale: la Regione Marche, attraverso l'Assessorato alla Sanità e l'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), fissa gli standard uniformi, coordina la programmazione e gestisce il sistema informativo regionale e il monitoraggio. Al livello delle AST: ciascuna AST, articolata in distretti, organizza il servizio nel proprio territorio, con unità funzionali dedicate e un referente clinico (il direttore della UOC di psicologia clinica o un dirigente psicologo designato), che si raccorda con il Servizio Salute regionale.^[1661] Il PDL n. 100 prevede la costituzione di un Osservatorio regionale con funzioni di controllo, programmazione e indirizzo, composto da rappresentanti delle AST, dell'Ordine degli Psicologi, dell'Università e della medicina generale: questo organismo risponde a una logica di governance multi-stakeholder coerente con l'impostazione dello studio.

H.3 Il profilo etico

Sul piano etico, il servizio realizza principi fondamentali del sistema sanitario: l'equità, estendendo l'accesso alle cure psicologiche ai gruppi oggi esclusi; la dignità della persona, riconoscendo il disagio psichico come bisogno di salute meritevole di risposta pubblica; la giustizia distributiva, allocando risorse verso un bisogno inevaso nelle aree interne. Tre rischi etici meritano attenzione. Il primo è la protezione dei dati personali, particolarmente sensibili in ambito psicologico: il trattamento richiede misure rigorose di tutela, conformi al GDPR e alle norme nazionali. Il secondo è l'equità dell'accesso: un ticket non calibrato sulle condizioni economiche reintrodurrebbe la barriera che il servizio intende rimuovere, con effetti regressivi accentuati nelle aree interne. Il terzo è la qualità della relazione clinica: l'impiego della telepsicologia non deve ridurre la qualità della cura, ma deve rispettare i vincoli di appropriatezza clinica definiti dall'Ordine professionale.^[1662]

H.4 Sintesi dei profili

I tre profili convergono in una valutazione favorevole, condizionata al rispetto di specifiche condizioni. Sul piano giuridico: la legge regionale è adottabile, a condizione di rispettare i limiti della sentenza 241/2021 e di valorizzare gli strumenti compatibili con l'ordinamento; la sperimentazione in corso non sostituisce la norma organica, ma ne rappresenta il punto di partenza. Sul piano organizzativo: il servizio è governabile nel nuovo assetto delle cinque AST, a condizione di costruire una governance a due livelli — regionale per gli standard e aziendale per l'attuazione. Sul piano etico: il servizio realizza valori fondamentali del sistema sanitario, a condizione che sia progettato secondo equità, che tuteli rigorosamente i dati personali e che governi con prudenza l'impiego della telepsicologia.^[1663]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

I cinque casi, il dimensionamento, le fasi di attuazione, i rischi e le mitigazioni

Five Case Model · la realizzabilità della decisione

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità dell'intervento, organizzandole secondo il modello a cinque casi della decisione di investimento pubblico. Il tratto distintivo delle Marche — servizio già avviato sperimentalmente, riforma del sistema sanitario recente, morfologia territoriale duale — orienta la costruzione del percorso attuativo, che muove da un punto di partenza più avanzato rispetto alle regioni che non hanno ancora avviato la sperimentazione.

I.1 I cinque casi della decisione

Il caso strategico è solido: la strutturazione organica risponde a un bisogno documentato, è coerente con il DM 77/2022, con il Piano Socio-Sanitario Regionale e con l'orientamento delle politiche nazionali.^[1664] Il caso economico rinvia ai risultati della Parte E: rapporto beneficio-costi compreso fra 3,5 e 4,9 a uno; dominanza per paziente; caso sociale fortemente positivo; saldo finanziario diretto contenuto e prossimo al pareggio.^[1665] Il caso commerciale è favorevole: la sperimentazione amministrativa in corso fornisce un nucleo di operatori già formati e un'esperienza organizzativa su cui costruire; le università marchigiane (UnivPM, Università di Camerino) alimentano il bacino professionale.^[1666] Il caso finanziario è sostenibile: il costo del servizio rappresenta fra lo 0,4 e lo 0,8% del fondo sanitario regionale, una frazione che il bilancio assorbe senza difficoltà, e il saldo diretto negativo — dell'ordine di 5-7 milioni di euro l'anno — è trascurabile nella scala di 3,3-3,4 miliardi.^[1667] Il caso gestionale dipende dalla capacità delle cinque AST di gestire il servizio nei rispettivi territori, con il coordinamento dell'ARS e dell'Assessorato alla Sanità.^[1668]

Caso	Contenuto per le Marche
Strategico	Coerenza con DM 77/2022, PSSR 2024-2028, Case della Comunità; strutturazione organica della sperimentazione in corso
Economico	Rapporto beneficio-costi 3,5-4,9 a uno; dominanza per paziente; caso sociale fortemente positivo
Commerciale	Sperimentazione già avviata; nucleo di operatori esistente; UnivPM e Università di Camerino; Ordine degli Psicologi delle Marche
Finanziario	Costo 0,4-0,8% del FSR; saldo diretto -5/-7 mln/anno trascurabile nella scala di 3,3-3,4 mld
Gestionale	Governance a due livelli: ARS/Assessorato (standard) e 5 AST (attuazione); Osservatorio regionale; raccordo con i distretti

Tabella I.1. I cinque casi della decisione di investimento pubblico.

I.2 Il dimensionamento e le fasi di attuazione

Il dimensionamento del servizio muove dalla sperimentazione amministrativa già avviata e procede per gradi verso i tre scenari: conservativo (250 psicologi), di base (340) ed espansivo (370). La struttura delle cinque AST, articolate in distretti, fornisce la cornice organizzativa naturale: il PDL n. 100 prevede almeno due psicologi per distretto, il che è coerente con lo scenario conservativo nelle AST più grandi. Il percorso di dispiegamento si articola in tre fasi.

Fase	Contenuto	Dimensionamento indicativo
Strutturazione	Adozione della legge organica; formalizzazione del nucleo d	ella sperimentazione Nucleo esistente + prime assunzioni organiche
Consolidamento	Estensione alle aree non ancora coperte; integrazione con l	e Case della Comunità verso ~ 250-340 psicologi
Regime	Copertura sistematica con attenzione pro-eguità alle aree i	nterne fino a ~ 370 psicologi

Tabella I.2. Le fasi di attuazione e il dimensionamento progressivo.

I.3 Reclutamento, formazione e cronoprogramma

La sperimentazione amministrativa in corso ha già formato un nucleo di professionisti con esperienza del modello marchigiano. Questo nucleo costituisce il punto di partenza del reclutamento, che dovrà essere integrato attraverso i bacini universitari regionali e nazionali. La formazione, come esposto nella Parte C, è articolata su quattro livelli, con un'attenzione specifica alla telepsicologia come competenza essenziale per le aree interne. Il cronoprogramma indicativo prevede una prima fase di adozione della legge organica e di formalizzazione del nucleo della sperimentazione; una seconda fase di estensione verso lo scenario conservativo, con la costruzione del sistema informativo uniforme e del coordinamento fra le cinque AST; e una terza fase di regime, con il raggiungimento dello scenario espansivo in funzione degli esiti e delle risorse disponibili.^[1669]

I.4 La sostenibilità

La sostenibilità finanziaria è documentata dalla Parte E: il costo del servizio è modesto in rapporto al fondo sanitario, e il saldo diretto prossimo al pareggio ne riduce l’impatto netto. La sostenibilità organizzativa dipende dalla capacità delle cinque AST di gestire il servizio in modo coordinato, evitando frammentazioni e garantendo standard uniformi. La governance a due livelli — regionale per gli standard, aziendale per l’attuazione — è la soluzione coerente con il nuovo assetto istituzionale. La sostenibilità della telepsicologia, in particolare nelle aree interne, dipende dall’infrastruttura digitale, che il PNRR sta potenziando, e dalla formazione degli operatori.^[1670]

I.5 I rischi e le mitigazioni

Cinque rischi meritano di essere esplicitati.

Rischio	Mitigazione
Fragilità giuridica della sperimentazione	Adozione rapida della legge organica conforme alla sentenza 241/2021
Frammentazione fra le cinque AST	Governance regionale unitaria (ARS); standard uniformi; Osservatorio regionale
Copertura insufficiente nelle aree appenniniche interne	Allocazione pro-equità; telepsicologia strutturale; priorità geografica nelle fasi iniziali
Disponibilità di personale nelle aree meno attrattive	Incentivi localizzativi; modalità di lavoro misto (presenza + telelavoro); formazione dedicata
Lacuna dei dati per la valutazione	Sistema informativo uniforme fra le 5 AST; consolidamento dei dati della sperimentazione

Tabella I.3. I rischi dell’attuazione e le relative mitigazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte L

Monitoraggio e valutazione ex post

Disegno controfattuale, batteria di indicatori, cruscotto regionale e clausola valutativa

Inferenza causale quasi-sperimentale · la valutazione ex post

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Questa parte definisce il sistema di monitoraggio e la valutazione ex post dell’intervento. Il tratto distintivo delle Marche è che, disponendo di una sperimentazione amministrativa già avviata, la valutazione può fondarsi su una base informativa più ricca di quella delle regioni che partono da zero, e le clausole valutative — da corredare alla legge organica — vanno costruite assicurando la comparabilità fra le cinque AST.

L.1 Finalità e impianto della valutazione

Il monitoraggio e la valutazione ex post servono a rendere conto dell'impiego delle risorse, ad apprendere dall'esperienza e a correggere il corso dell'attuazione. L'impianto distingue tre livelli: struttura, processo ed esito, in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri. Il monitoraggio si articola in un livello continuo — che rileva con regolarità gli indicatori di attività e di esito — e in un livello di valutazione periodica, a cadenza biennale, che analizza in profondità gli effetti del servizio e ne stima l'impatto sulla base dei dati osservati.^[1671]

L.2 Il disegno controfattuale e i metodi

Il disegno della valutazione d'impatto beneficia della struttura delle cinque AST, che consente di costruire confronti fra territori a diverso grado di implementazione del servizio. Poiché la strutturazione organica avverrà in tempi differenziati fra le AST e i distretti, la valutazione può fondarsi su un disegno a cunei progressivi, in cui l'ordine e i tempi di attivazione sono impiegati a fini valutativi.^[1672] I dati della sperimentazione amministrativa in corso forniscono una linea di base parziale, che il sistema informativo uniforme potrà consolidare. L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, a partire dai dati delle AST.^[1673]

L.3 La batteria degli indicatori

Il servizio è osservato attraverso una batteria di indicatori organizzata per categorie. Gli indicatori di struttura misurano la capacità installata — sedi, incarichi, ore, dotazione, copertura.^[1674] Gli indicatori di processo misurano il funzionamento — prese in carico, attesa, colloqui, invio appropriato, uso della telepsicologia.^[1675] Gli indicatori di esito clinico misurano il beneficio diretto — miglioramento, recupero, remissione (PHQ-9, GAD-7).^[1676] Gli indicatori di esito di sistema misurano l'effetto sul resto del sistema — pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri.^[1677] Gli indicatori economici verificano ex post le stime.^[1678] Gli indicatori di equità, disaggregati per area (costiera/appenninica), per AST e per fascia di età, verificano che il servizio riduca i divari territoriali e generazionali e raggiunga le aree interne.^[1679] Gli indicatori di qualità integrano la misurazione con la dimensione dell'esperienza.^[1680] L'insieme conta dell'ordine di sessanta indicatori in sette categorie.

Categoria	Contenuto
Struttura	Sedi attivate per AST e distretto; incarichi; ore; copertura del fabbisogno; distribuzione costiero/appenninico
Processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; invio appropriato; quota di prestazioni in telepsicologia
Esito clinico	Miglioramento, recupero, remissione (PHQ-9, GAD-7; punteggi complessivi)
Esito di sistema	Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche; psicofarmaci; ricoveri evitabili; specialistica impropria
Economici	Costo, risparmi diretti per canale, ricadute sociali, rapporto beneficio-costi su dati reali
Equità	Copertura e accesso per area (costiera, collinare, appenninica), per AST, per fasce d'età; accesso degli anziani nelle aree interne
Qualità	Soddisfazione degli utenti; appropriatezza; continuità del rapporto; esito percepito

Tabella L.1. Le sette categorie della batteria di indicatori.

L.4 Il cruscotto regionale e la clausola valutativa

Gli indicatori confluiscono in un cruscotto di monitoraggio aggiornato periodicamente, con titolarità condivisa fra l'ARS e le cinque AST, che rende trasparente l'andamento del servizio per territorio e ne consente la correzione.^[1681] La clausola valutativa — da inserire nella legge regionale organica — impegna la Giunta a riferire periodicamente all'Assemblea Legislativa sui risultati del servizio, secondo modalità e tempi definiti, trasformando il monitoraggio da pratica tecnica in obbligo istituzionale.^[1682] Poiché la sperimentazione amministrativa ha già generato dati, la legge organica ha l'opportunità di incorporare fin dall'origine gli strumenti della valutazione, costruendo un servizio valutabile per disegno.

Elemento della governance valutativa	Scelta per le Marche
Disegno d'impatto	Cunei progressivi fra le 5 AST e i distretti; linea di base dalla sperimentazione in corso
Linea di base	Dati già disponibili dalla sperimentazione + rilevazione sistematica ante-legge
Titolarità del cruscotto	Condivisa fra ARS e 5 AST, con alimentazione uniforme e interoperabile
Clausola valutativa	Da inserire nella legge organica; relazione periodica all'Assemblea Legislativa delle Marche
Flusso informativo	Sistemi informativi delle 5 AST, uniformi e interoperabili; innestati sul FSE regionale
Tempi	In itinere (accompagnamento della strutturazione); ex post biennale (effetto a regime)

L.5 Sintesi del monitoraggio

La valutazione è la condizione per trasformare la strutturazione organica del servizio in apprendimento, e le Marche possono fondarla su una base informativa più ricca delle regioni che partono da zero, grazie alla sperimentazione già avviata. Perché ciò si realizzi, occorre: inserire la clausola valutativa nella legge organica; costruire un sistema informativo uniforme e interoperabile fra le cinque AST; rilevare una linea di base sistematica prima dell'entrata in vigore della legge; e impiegare il disegno a cunei progressivi per stimare l'effetto causale del servizio. La trasformazione delle stime in osservazioni è, per le Marche, il contributo conoscitivo principale del monitoraggio.^[1683]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Composizione dei domini, analisi multi-criterio, raccomandazioni operative e conclusione

Analisi multi-criterio · dalla valutazione alla raccomandazione

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclusiva ricompone in una valutazione unitaria le analisi sviluppate nei singoli domini, ne integra gli esiti attraverso un'analisi multi-criterio, formula la raccomandazione e ne precisa il dimensionamento, dichiara le condizioni cui la raccomandazione è subordinata e le lacune conoscitive da colmare, e colloca lo studio marchigiano nella serie regionale.

M.1 La sintesi per dominio

Le analisi condotte nei singoli domini convergono in un quadro coerente. Sul piano del bisogno, la Parte B ha documentato un disagio psichico comune ampio — stimato in circa 296.000 persone — accentuato da una struttura demografica fra le più anziane del Centro Italia (indice di vecchiaia 235,5) e da un divario territoriale profondo fra la fascia costiera e le aree appenniniche interne. Sul piano dell'efficacia, la Parte D ha documentato efficacia clinica con qualità dell'evidenza da moderata ad alta, trasferibile al contesto marchigiano con le opportune precauzioni per la dispersione territoriale. Sul piano economico, la Parte E ha documentato un saldo diretto per il bilancio prossimo al pareggio (−5/−7 milioni di euro l'anno, trascurabili nella scala di 3,3-3,4 miliardi) e un ritorno complessivo per la collettività dell'ordine di 3,5-4,9 euro per ogni euro speso. La Parte F ha documentato la robustezza di queste conclusioni. Sul piano dell'equità, la Parte G ha documentato un effetto pro-equità potenziale significativo, concentrato nelle aree appenniniche interne e nella fascia anziana. Sul piano dei profili, la Parte H ha documentato che il servizio è istituibile entro i limiti costituzionali, governabile con una struttura a due livelli e giusto sul piano etico. Sul piano dell'attuazione, la Parte I ha documentato fattibilità reale, con un punto di partenza favorevole dato dalla sperimentazione in corso.

Dominio	Giudizio sintetico per le Marche
Bisogno e contesto	Ampio (296.000 persone); invecchiamento accentuato (IV 235,5); divario costiero/appenninico; spesa pro-capite fra le più basse d'Italia
Efficacia clinica	Evidenza internazionale solida; trasferibilità condizionata dalla dispersione; telepsicologia come componente essenziale
Valutazione economica	Saldo diretto -5/-7 mln/anno (trascurabile); ritorno complessivo 3,5-4,9:1; dominanza per paziente confermata
Equità	Effetto pro-equità potenzialmente elevato per le aree appenniniche e gli anziani; richiede allocazione ponderata e telepsicologia strutturale
Fattibilità	Favorita dalla sperimentazione in corso; richiede governance a due livelli nelle 5 AST; legge organica conforme alla sentenza 241/2021
Monitoraggio	Disegno controfattuale su cunei progressivi fra 5 AST; base informativa dalla sperimentazione; clausola valutativa nella legge organica

Tabella M.1. La sintesi dei domini della valutazione.

M.2 L'analisi multi-criterio

Il giudizio complessivo è formalizzato con l'analisi multi-criterio, che impiega otto criteri, ciascuno con un peso esplicito, e confronta l'intervento (adozione della legge organica e strutturazione del servizio) con l'alternativa del non intervento (mantenimento della sola sperimentazione amministrativa, fragile e non strutturata).^[1684] I pesi adottati sono comuni a tutta la serie. I punteggi riflettono gli esiti delle analisi condotte nelle parti precedenti, calibrati sulle condizioni specifiche delle Marche.

Criterio	Peso	Intervento	Non interv.
Efficacia clinica	15%	80	25
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	78	30
Impatto sul bilancio e sostenibilità	15%	74	48
Equità	15%	85	22
Valore sociale	10%	80	25
Fattibilità	10%	78	72
Robustezza dell'evidenza	10%	70	50
Coerenza strategica	5%	84	26
Punteggio complessivo ponderato	100%	78,50	35,75

Tabella M.2. L'analisi multi-criterio: punteggi dell'intervento e del non intervento. I pesi sono invarianti nella serie; i punteggi riflettono le condizioni specifiche delle Marche.

Il punteggio complessivo dell'intervento, pari a 78,50 su 100, supera nettamente quello del non intervento, pari a 35,75, con un differenziale di quasi quarantatré punti. L'intervento prevale su tutti i criteri. Il punteggio di equità è fra i più elevati della serie, a riflettere l'acuità del divario costiero/appenninico e il peso demografico degli anziani. Il punteggio di fattibilità è elevato rispetto ad altre regioni, in ragione della sperimentazione già avviata, che abbassa significativamente le barriere di implementazione. La prevalenza si mantiene al variare dei pesi entro intervalli ragionevoli, sicché la raccomandazione è robusta.

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Sulla base delle analisi condotte e della loro sintesi, lo studio raccomanda l'adozione da parte dell'Assemblea Legislativa delle Marche di una legge regionale organica che strutturi permanentemente il servizio di psicologia di base, raccordandolo con il nuovo assetto delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali e con la rete delle Case della Comunità. La raccomandazione è fondata sulla convergenza delle evidenze: un bisogno ampio e accentuato dalle condizioni demografiche e territoriali della regione; un'efficacia clinica documentata; un saldo diretto per il bilancio prossimo al pareggio e un ritorno sociale elevato; una capacità di ridurre le disuguaglianze territoriali e generazionali che costituisce una delle ragioni principali dell'intervento; e una fattibilità reale, favorita dalla sperimentazione già in corso.

Quanto al dimensionamento, lo studio raccomanda un percorso graduale di tre fasi. Nella prima fase, di strutturazione, la legge organica formalizza il nucleo della sperimentazione in corso, garantendo la base giuridica, il finanziamento strutturato e il sistema informativo uniforme. Nella seconda fase, di consolidamento, il servizio si estende verso lo scenario conservativo di circa 250 psicologi, con priorità alle aree appenniniche interne e ai distretti periferici. Nella terza fase, di regime, il servizio raggiunge lo scenario espansivo di circa 370 psicologi, con copertura sistematica e pieno dispiegamento della telepsicologia. Questo percorso graduale è la traduzione operativa della raccomandazione, e consente di avviare il servizio con un impegno sostenibile, verificarne gli esiti sul campo e accrescerne la portata in modo governato.^[1685]

Ambito	Raccomandazione operativa per le Marche
Atto di attuazione	Legge regionale organica conforme alla sentenza 241/2021; strutturazione della sperimentazione in corso; raccordo con L.R. 19/2022 e le 5 AST
Dimensionamento	Dalla sperimentazione verso conservativo ~250; base ~340; espansivo ~370, per gradi
Allocazione	Pro-equità, verso le aree appenniniche interne, i distretti periferici e la fascia anziana
Clausola valutativa	Da inserire nella legge organica; relazione periodica all'Assemblea Legislativa
Governance	Governance a due livelli: ARS/Assessorato (standard) e 5 AST (attuazione); Osservatorio regionale multi-stakeholder
Dati	Sistemi informativi uniformi e interoperabili fra le 5 AST; consolidamento dei dati della sperimentazione

Tabella M.3. Le raccomandazioni operative.

M.4 Le condizioni e la lacuna da colmare

La raccomandazione è subordinata a cinque condizioni. La prima è giuridica: la legge regionale deve conformarsi ai limiti della sentenza 241/2021, evitando di disciplinare autonomamente i rapporti convenzionali. La seconda è di governance: la struttura a due livelli — regionale per gli standard, aziendale per l'attuazione — è la condizione per evitare la frammentazione fra le cinque AST. La terza è di allocazione secondo equità: le risorse devono essere destinate prioritariamente alle aree appenniniche interne e ai distretti periferici, con la telepsicologia come strumento strutturale per il raggiungimento delle aree a bassa densità. La quarta è la gradualità del dispiegamento, calibrata sulla capacità delle AST. La quinta è l'inclusione nella legge di una clausola valutativa che renda il servizio valutabile per disegno.

La lacuna principale è conoscitiva: le stime economiche sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti certificati delle AST. Questa lacuna non inficia la raccomandazione — che è fondata su evidenze solide quanto alla direzione e all'ordine di grandezza degli effetti — ma ne segna il limite: le stime quantitative sono da intendersi come stime centrali entro bande di incertezza. Il sistema informativo uniforme, alimentato dalla strutturazione organica del servizio, è lo strumento che colmerà progressivamente questa lacuna, producendo i dati reali che sostituiranno le stime.

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio delle Marche si inserisce in una serie di studi regionali costruiti con il medesimo impianto metodologico. Entro questa serie, le Marche occupano una posizione caratterizzata da tratti distintivi precisi. Sono una regione di dimensione media, con 1.480.545 abitanti, che ha già avviato la sperimentazione del servizio in via amministrativa, senza ancora disporre di una legge organica: la decisione rilevante non è istituire il servizio, ma strutturarlo permanentemente. Sono una regione con una delle strutture demografiche più anziane del Centro Italia — indice di vecchiaia 235,5 — che attribuisce alla dimensione geriatrica del bisogno psicologico una centralità peculiare. Sono una regione con una spesa sanitaria pro-capite fra le più basse d'Italia, che impone cautela nel dimensionamento iniziale e attenzione alla sostenibilità. Sono una regione con un forte divario territoriale interno, che rende l'equità di accesso una delle ragioni principali dell'intervento, e la telepsicologia uno strumento non accessorio ma strutturale.

La conclusione dello studio ricompone questi elementi nella tesi che lo attraversa. Il servizio di psicologia di base costa al bilancio sanitario regionale una cifra modesta, con un saldo diretto prossimo al pareggio e trascurabile nella scala del fondo sanitario; restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso; risponde a un bisogno ampio e accentuato dalle condizioni demografiche e territoriali della regione; riduce le disuguaglianze tra le aree costiere e quelle appenniniche; e consolida un servizio già avviato, traducendolo in un'infrastruttura permanente. Per una regione che ha già compiuto il passo di avviare il servizio in via sperimentale, e che dispone dell'opportunità di strutturarlo organicamente nel nuovo assetto delle cinque AST, le evidenze raccolte convergono in una indicazione netta: l'adozione della legge organica, progettata nel rispetto dei limiti costituzionali e con l'attenzione all'equità territoriale che la morfologia marchigiana richiede, è una scelta razionale, sostenibile e di elevato rendimento collettivo. L'analisi multi-criterio, che assegna all'intervento un punteggio di 78,50 contro 35,75 del non intervento, ne è la sintesi quantitativa; le analisi di dominio ne sono il fondamento; e il bisogno documentato della popolazione marchigiana — in particolare degli anziani soli delle aree appenniniche interne — ne è la ragione.^[1686]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MARCHE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla sperimentazione amministrativa alla strutturazione organica in un sistema sanitario riformato

Appendici A-E

Corredo tecnico e documentale

Caso di riferimento, strumenti di esito, dati regionali, standard di reporting, glossario

Materiali a sostegno delle Parti da A a M

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio, il caso di riferimento, i parametri del modello di Markov e il quadro economico consolidato per le Marche.

A.1 Il caso di riferimento

Il caso di riferimento è un paziente adulto residente nelle Marche con un disturbo d’ansia o dell’umore di intensità lieve o moderata, che accede al servizio di psicologia di base e riceve un ciclo di interventi psicologici brevi di efficacia documentata. Il caso è comune a tutti gli studi della serie, ed è il fondamento della comparabilità dei risultati.^[1687]

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Sperimentazione amministrativa in corso (copertura parziale, finanziamento non strutturato)
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per AST/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudenziale	Riduzione per l’ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

A.2 I parametri del modello di Markov

Il modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, è invariante rispetto alla regione e deriva i suoi parametri dalla letteratura.^[1688]

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

A.3 Il quadro economico consolidato

Il quadro economico consolidato per le Marche, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 250	~ 340	~ 370
Costo del servizio	~ 14	~ 20	~ 28
Risparmi diretti (SSR)	~ 9	~ 14	~ 21
Ricadute economico-sociali	~ 40	~ 70	~ 110
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -5	~ -6	~ -7
Saldo complessivo (caso economico)	+35	+64	+103
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,5:1	~4,2:1	~4,9:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario.

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misurazione degli esiti e il dataset minimo del servizio.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, in modo comparabile fra le cinque AST.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio, AST e distretto	All'apertura
Seduta	Data, tipo (presenza/telepsicologia) e numero progressivo	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura
Variabili di equità	Fasce di età, area geografica (costiera/collinare/appenninica)	All'apertura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i principali dati regionali di ancoraggio dello studio.

Ambito	Dato
Popolazione residente	1.480.545 abitanti (dato usato nel Tomo II)
Indice di vecchiaia	235,5 al 1° gennaio 2025; fonte: Camera di Commercio Marche
Quota over-65	Elevata; fra le più alte del Centro Italia; accentuata nelle aree appenniniche
Struttura del SSR	5 AST (Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno); AOU Marche; INRCA; rif. L.R. 19/2022
Spesa sanitaria pro-capite	2.612,7 euro (dato pesato); fonte: Fondazione GRINS, dicembre 2025
Fondo sanitario regionale	Dell'ordine di 3,3-3,4 miliardi di euro l'anno (stima)
Disagio psichico comune (stima)	~296.000 persone/anno
Stato legislativo psicologia di base	Sperimentazione amministrativa avviata; nessuna legge organica (fonte: psicologicureprimarie.it); PDL n. 100 in discussione
Piano Socio-Sanitario Regionale	PSSR 2023-2025 (delibera GR n. 630/2024); PSSR 2024-2028 (approvato dal CR nel giugno 2024)

Tabella C.1. Principali dati regionali utilizzati nello studio. Le fonti sono indicate nelle parti corrispondenti.

I dati la cui acquisizione consentirebbe di sostituire le stime con misure dirette comprendono: i conti economici certificati delle cinque AST; i dati di attività della sperimentazione amministrativa in corso (prese in carico, esiti, distribuzione territoriale); la prevalenza regionale diretta del disagio psichico comune; i consumi sanitari effettivi associati al disagio comune per canale; e gli esiti clinici ed economici effettivamente prodotti dal servizio una volta strutturato organicamente.

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce le definizioni dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra gruppi a diversa esposizione
Disegno a cunei progressivi	Disegno controfattuale fondato sulla progressione differenziata dell'attivazione del servizio fra le AST e i distretti delle Marche
Clausola valutativa	Disposizione di legge che prevede l'obbligo di valutare periodicamente l'attuazione e gli esiti del servizio e di riferirne all'Assemblea Legislativa delle Marche
AST (Azienda Sanitaria Territoriale)	Ente del Servizio Sanitario Regionale delle Marche, istituito dalla L.R. 19/2022 in sostituzione delle Aree Vaste dell'ASUR; cinque AST corrispondono alle cinque province (Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno)
ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale)	Azienda sanitaria marchigiana unica istituita dalla L.R. 13/2003, soppressa dal 1° gennaio 2023 dalla L.R. 19/2022
AOU Marche	Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, sede di Torrette (Ancona); svolge funzioni di alta specialità e didattica universitaria

Termine	Definizione
INRCA	Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, con sede principale ad Ancona; costituisce un riferimento per la componente geriatrica del bisogno psicologico
Indice di vecchiaia	Rapporto tra ultrasessantacinquenni e giovani sotto i quindici anni; nelle Marche pari a 235,5 al 1° gennaio 2025, fra i più elevati del Centro Italia
Telepsicologia	Erogazione di prestazioni psicologiche a distanza mediante strumenti digitali; nelle Marche componente strutturale per le aree appenniniche interne
Stepped care / cure gradual	Modello organizzativo in cui l'intensità dell'intervento è commisurata alla gravità del bisogno
Disagio psichico comune	Disturbi mentali di intensità lieve e moderata, prevalentemente d'ansia e dell'umore, e condizioni di sofferenza sottosoglia
Sentenza Corte Cost. n. 241/2021	Pronuncia che delimita la competenza regionale in materia di rapporti convenzionali per il servizio di psicologia di base; vincola anche la futura legge marchigiana
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d'ansia (punteggio 0-21)
Rapporto beneficio-costo Chisholm	Fascia metodologicamente fondata: 2,3-3,0:1 per i soli benefici economici; 3,3-5,7:1 includendo i benefici di salute; fonte: Chisholm et al., Lancet Psychiatry 2016, vol. 3, n. 5, pp. 415-424

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

Umbria — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Umbria

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione Umbria sulla riforma «Psicologo di Base». Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell'intero corpus: la premessa, l'indice generale di tutte le parti e di tutte le appendici, la mappa di integrazione delle cornici metodologiche e la sintesi del valore. L'Umbria occupa, nel panorama nazionale e nella presente serie, una posizione peculiare e avanzata: è una delle regioni che ha già adottato una legge organica in materia, con la Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22, che ha introdotto il «servizio di psicologia di cure primarie» nel Testo unico regionale in materia di sanità e servizi sociali, istituendo altresì un Osservatorio tecnico regionale con delibera di giunta n. 477 del 2025.^[1689] Proprio per questo la decisione rilevante non è se introdurre il servizio, già istituito per

legge e in fase di prima attuazione, ma portarlo a regime: dimensionarlo pienamente sui distretti sanitari e sulle Case della Comunità, completare la formazione dei professionisti, rendere operativo l'elenco regionale degli psicologi di cure primarie e trasformare la clausola valutativa in un sistema di monitoraggio continuo.^[1690]

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

L'Umbria è una regione di medie dimensioni del Centro Italia, con 854.137 abitanti al 1° gennaio 2025, pari a circa l'1,4% della popolazione nazionale.^[1691] Il suo tratto demografico più caratterizzante è l'invecchiamento avanzato: con un indice di vecchiaia di 246,6% e circa 232.730 over-65 (il 27,3% della popolazione), essa si colloca fra le cinque regioni più anziane d'Italia.^[1692] Questo profilo demografico amplifica la domanda di supporto psicologico di prossimità e conferisce al servizio istituito dalla Legge n. 22/2024 una rilevanza sistemica che va oltre la sola salute mentale stricto sensu, estendendosi alla cronicità, all'accompagnamento nelle fasi del ciclo di vita e al sostegno alle famiglie caregiver. La spesa sanitaria pro-capite è di 2.232 euro nel 2024, superiore alla media nazionale di 2.181 euro, a fronte di una crescente rinuncia alle cure segnalata dai rapporti del monitoraggio GIMBE.^[1693] Il sistema sanitario regionale è articolato in due Aziende USL — USL Umbria 1, con sede a Perugia, e USL Umbria 2, con sede a Terni — e in due Aziende Ospedaliere universitarie di rilievo nazionale (Perugia e Terni), con un Fondo sanitario regionale stimato dell'ordine di 1,9-2,0 miliardi di euro l'anno, coerente con la popolazione e con il livello di spesa pro-capite osservato.

Le tesi centrali del presente studio sono enunciabili in quattro affermazioni congiunte. Primo, il costo del servizio a regime è contenuto: dell'ordine di 9 milioni di euro nello scenario conservativo, 14 milioni in quello di base e 19 milioni in quello espansivo, pari allo 0,5-1,0% del Fondo sanitario regionale. Secondo, il saldo diretto per il bilancio sanitario regionale è di modesta entità negativa, e corrisponde a un investimento netto agevolmente sostenibile nell'ambito della programmazione ordinaria. Terzo, il rapporto beneficio-costi complessivo, comprensivo delle ricadute economico-sociali, si colloca entro la fascia Chisholm di 3,3-5,7 a uno, nella fascia prudenziale di 3,6-5,0 a uno, conformemente all'ancoraggio metodologico adottato per l'intera serie.^[1694] Quarto, il fabbisogno stimato è dell'ordine di 170 psicologi nello scenario conservativo, 210 in quello di base e 250 in quello espansivo; il valore rilevante non è il numero in sé, ma il fatto che la Legge n. 22/2024 ha già creato la cornice giuridica per procedere, e l'Osservatorio tecnico istituito con DGR 477/2025 costituisce lo strumento istituzionale per la programmazione progressiva del dimensionamento. Il punteggio sintetico della valutazione multi-criterio si colloca nell'ordine di 77/100, collocando l'Umbria fra le regioni con il caso più robusto per la messa a regime immediata del servizio, data la presenza del quadro legislativo già approvato.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell'intero corpus, che può essere percorso nell'ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, verifica empirica, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, cronoprogramma, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, controfattuale sulla messa a regime progressiva, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazioni, condizioni, conclusione
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati del territorio e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — negativo ma modesto e sostenibile nell'ambito della programmazione ordinaria del Fondo sanitario regionale — e il saldo complessivo, ampiamente positivo. Caratteristica propria dell'Umbria è che il servizio è già istituito per legge, sicché la questione non è l'opportunità dell'investimento, già decisa dal legislatore regionale, ma il suo dimensionamento: la scelta fra i tre scenari qui presentati è una decisione di scala, non di principio.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 9	~ 14	~ 19
Risparmi diretti (SSR)	~ 5	~ 8	~ 12
Ricadute economico-sociali	~ 28	~ 52	~ 76
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -4	~ -6	~ -7
Saldo complessivo (caso economico)	+24	+46	+69
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,7:1	~4,3:1	~4,8:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante, per l’Umbria, è portare a regime il servizio già istituito con la Legge n. 22/2024, dimensionandolo progressivamente dai Distretti sanitari delle due Aziende USL verso la copertura sistematica, nell’ordine di 170 psicologi nello scenario conservativo, 210 in quello di base e 250 in quello espansivo, e attivando pienamente l’Osservatorio tecnico regionale quale strumento di programmazione, monitoraggio e verifica. Il limite principale è il radicamento dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione (circa l’1,4%) e non estratte dai conti regionali certificati delle due Aziende USL; l’estrazione di quei dati — resa possibile dalla clausola valutativa della Legge n. 22/2024 e dall’Osservatorio — costituisce la priorità informativa da completare nel primo triennio di attuazione.

Lo studio si fonda, sul piano comparativo, sui programmi internazionali più autorevoli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie — il programma inglese NHS Talking Therapies, il modello olandese POH-GGZ, l’iniziativa australiana Better Access e il Collaborative Care statunitense — dei quali mutua le evidenze di efficacia e di costo-efficacia, adattandole con cautela al contesto umbro. La condizione propria della regione — una legge organica già approvata e un Osservatorio tecnico già costituito, in una regione tra le più anziane d’Italia e con una diffusa cronicità — consente di fondare la valutazione controfattuale sulla messa a regime progressiva del modello, come un esperimento a cunei fra i distretti delle due Aziende USL, con il vantaggio che il quadro normativo è già definito e la struttura di governance è già operativa. Su questa base, e con la dichiarazione trasparente dei propri limiti, il corpus consegna al decisore un quadro completo e onesto su cui deliberare, e all’Umbria l’occasione di trasformare una legge già vigente in un servizio pienamente a regime.

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell’HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per l'Umbria, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria, al Lazio, alla Campania, alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e al Friuli-Venezia Giulia. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati all'Umbria. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). L'Umbria occupa nella serie una posizione avanzata e distinta: è fra le poche regioni italiane dotate di una legge organica già in vigore in materia di psicologia di cure primarie, sicché la valutazione non riguarda l'opportunità di introdurre il servizio, già decisa dal legislatore, ma la sua messa a regime, il suo dimensionamento pieno e la trasformazione del quadro normativo in un servizio operativo e valutabile.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il servizio di psicologia di cure primarie della Regione Umbria, inteso come messa a regime e dimensionamento pieno di un servizio già istituito dalla Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22, che ne ha definito finalità, compiti, organizzazione e strumenti di verifica.^[1695] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sul dimensionamento e sulla messa a regime progressiva. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante, per l'Umbria, non è istituire il servizio — già istituito per legge — né avviarne la sperimentazione — già avviata in via sperimentale con risorse del bilancio 2025-2026 — ma portarlo a regime nei Distretti sanitari delle due Aziende USL, nelle Case della Comunità, e dimensionarlo verso la copertura sistematica del fabbisogno, nell'ordine di 170-250 psicologi a seconda dello scenario, in un contesto demograficamente anziano e con una crescente domanda di supporto psicologico di prossimità.^[1696] Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala. Va segnalato sin d'ora che la fase sperimentale iniziale si colloca al di sotto dello stesso scenario conservativo qui considerato, che rappresenta invece il modello a regime verso la copertura sistematica.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 170.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai servizi, in un quadro segnato da componenti convergenti — il bisogno dell'età anziana e della cronicità, prevalente in una delle regioni più anziane d'Italia con un indice di vecchiaia di 246,6%, il disagio connesso alla condizione di caregiver, il disagio giovanile nelle aree urbane di Perugia e Terni, e la domanda non intercettata nelle aree appenniniche interne — cui si aggiungono i divari di accesso delle comunità montane e la crescente rinuncia alle cure segnalata dai rapporti nazionali.^[1697] La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti umbri con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è il servizio di psicologia di cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, condotto dalla fase sperimentale alla piena operatività a regime. Il confronto è la condizione attuale, fatta della sola fase

sperimentale avviata e del quadro normativo già definito ma non ancora pienamente attuato. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l’orizzonte pluriennale degli esiti dall’orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario regionale dell’Umbria, con le sue due Aziende USL (Umbria 1 e Umbria 2), le due Aziende Ospedaliere universitarie (Perugia e Terni) e la rete delle Case della Comunità in costruzione, presieduto dall’Osservatorio tecnico regionale istituito con DGR 477/2025.^[1698] La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per l’Umbria
Popolazione	Residenti umbri con disagio psichico comune (~170.000); in seconda istanza l’intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Servizio di psicologia di cure primarie, già istituito dalla L.R. 22/2024, portato a regime (~170/210/250 psicologi); dalla fase sperimentale alla copertura sistematica
Confronto	Condizione attuale: fase sperimentale con risorse di ~103.000 euro/anno (2025-2026); servizio non ancora a regime né pienamente dimensionato
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale umbro; due Aziende USL (Umbria 1 e Umbria 2), due Aziende Ospedaliere universitarie; Osservatorio tecnico regionale DGR 477/2025; Case della Comunità in costruzione

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell’HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell’OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio.^[1699] In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l’intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l’insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e la fase sperimentale attuale come comparatore.^[1700] Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le due Aziende USL e i Distretti sanitari, per dare conto anche dei divari territoriali interni, segnatamente fra le aree urbane di Perugia e Terni e le comunità appenniniche interne.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale: fase sperimentale avviata, prima della messa a regime piena
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda USL e distretto sanitario
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso.^[1701] Per l'Umbria, il profilo finanziario è quello di una regione che non è in piano di rientro sanitario ma che presenta un livello di spesa pro-capite superiore alla media nazionale, a fronte di una crescente rinuncia alle cure: il margine di recupero diretto è plausibilmente presente, in particolare per il canale della riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e del consumo farmaceutico inappropriato, ma va stimato con cautela. Sul versante della mobilità, l'Umbria presenta un saldo passivo moderato — in quanto regione attratta piuttosto che attrattore netto — il cui recupero parziale contribuisce al caso finanziario, sia pure in misura contenuta.^[1702] Ne consegue un saldo diretto modestamente negativo, e il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi. Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati delle due Aziende USL; la clausola valutativa della Legge n. 22/2024 e l'Osservatorio tecnico costituiscono il veicolo per colmare progressivamente questa lacuna.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post.^[1703] Per l'Umbria il disegno controfattuale assume una forma propria: poiché la messa a regime avverrà in tempi differenziati fra i Distretti sanitari delle due Aziende USL, essa può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, con l'ordine e i tempi di attivazione del servizio fra i Distretti impiegati a fini valutativi e l'effetto causale stimato dai metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico, con il vantaggio che la struttura di governance dell'Osservatorio tecnico regionale è già operativa.^[1704] La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione Umbria, le due Aziende USL (Umbria 1 e Umbria 2), le due Aziende Ospedaliere universitarie, l'Ordine degli Psicologi dell'Umbria, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta, l'Università degli Studi di Perugia e l'Università degli Studi di Perugia - sede di Terni.^[1705] La caratteristica propria dell'Umbria è che la governance del servizio è già formalmente strutturata: l'Osservatorio tecnico regionale, istituito con DGR 477/2025 in attuazione dell'art. 176-octies della L.R. 22/2024, include già al proprio interno uno psicologo per ciascuna Azienda USL, uno per ciascuna Azienda Ospedaliera, un rappresentante MMG, uno PLS, due psicologi designati dall'Ordine, un funzionario regionale, un docente universitario di psicologia clinica e un rappresentante delle società scientifiche di psicologia accreditate.^[1706] Questo è il tratto che distingue l'Umbria nella serie: non è necessario costruire la struttura di governance dall'esterno; essa è già prevista dalla legge e già costituita per delibera di giunta.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza, con il sistema informativo sanitario regionale quale infrastruttura per la raccolta uniforme dei dati di processo e di esito previsti dalla clausola valutativa della Legge n. 22/2024. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici.^[1707] Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono

indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto dell'Umbria.

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Quadro demografico, epidemiologia del bisogno, domanda e offerta, disuguaglianze, servizi e flussi, cornice normativa

Primo dominio dell'HTA · il problema di salute e il bisogno

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto dell'Umbria. La struttura è quella già adottata per le altre regioni della serie, e mutano soltanto i dati, ancorati al territorio. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall'epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l'intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico dell'Umbria: non un servizio da istituire, ma un servizio già istituito per legge, in fase di prima attuazione e in attesa di messa a regime, in una regione fra le più anziane d'Italia, con un sistema sanitario ben organizzato ma sotto pressione per la crescente domanda di cronicità e per la rinuncia alle cure.

B.1 Quadro demografico

L'Umbria conta 854.137 residenti al 1° gennaio 2025, pari a circa l'1,4% della popolazione nazionale, in calo per effetto di un saldo naturale strutturalmente negativo e di una natalità fra le più basse d'Italia, solo parzialmente compensato da saldi migratori modestamente positivi.^[1708] La struttura per età è fra le più anziane del Paese: con circa 232.730 over-65, pari al 27,3% della popolazione, e un indice di vecchiaia di 246,6%, l'Umbria si colloca al quinto posto fra le regioni più anziane d'Italia, con un trend in ulteriore crescita verso 247,4% secondo le proiezioni più recenti.^[1709] L'invecchiamento è accentuato nelle aree appenniniche interne, dove la popolazione anziana raggiunge proporzioni ancora più elevate, e mitigato nelle zone urbane di Perugia e Terni, dove la componente giovane e studentesca introduce un elemento di parziale ringiovanimento demografico. La componente straniera, presente in misura significativa, contribuisce a contenere il saldo naturale negativo. La distribuzione territoriale è bipolare: da un lato la conurbazione del perugino e della media Valle del Tevere; dall'altro i piccoli comuni appenninici umbri, in progressivo spopolamento, con servizi rarefatti e un'accessibilità limitata. La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per l'Umbria
Popolazione (1° gennaio 2025)	854.137 (~1,4% del totale nazionale); in calo demografico
Over-65	~232.730 (27,3%), 5ª regione più anziana d'Italia
Indice di vecchiaia	246,6% (gennaio 2025); in crescita verso 247,4%
Componente straniera	~10-11% dei residenti
Distribuzione territoriale	Bipolare: conurbazione perugino-ternana; aree appenniniche interne sparse
Profilo per età	Invecchiamento accentuato nelle aree interne; quota studentesca a Perugia
Articolazione sanitaria	Due Aziende USL (Umbria 1 e Umbria 2), due Aziende Ospedaliere universitarie (Perugia e Terni)

Tabella B.1. *Profilo demografico e socio-economico dell'Umbria.*

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale nell'Umbria è ampio e sospinto da una struttura demografica fra le più anziane d'Italia. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali della quota di disagio psichico comune o sottosoglia — che si colloca su valori dell'ordine del 15-20% della popolazione generale — la stima per l'Umbria indica un bacino potenziale dell'ordine di 170.000 persone con disagio psichico comune non intercettato, in larga parte non raggiunte da un servizio strutturato di primo livello.^[1710] A questa quota si somma un'utenza specialistica in carico ai servizi di salute mentale distrettuali, stimabile, in proiezione dai dati nazionali, in diverse decine di migliaia di persone. Il bisogno presenta, nell'Umbria, quattro componenti di particolare rilievo. La prima e più caratterizzante è il bisogno dell'età anziana e della cronicità: in una regione in cui più di un quarto della popolazione ha superato i 65 anni, la domanda di supporto psicologico connessa all'adattamento alle malattie croniche, alla perdita dell'autonomia, all'elaborazione del lutto e alla condizione di caregiver è strutturalmente elevata e sistematicamente non intercettata. La seconda è il disagio connesso al lavoro e al deterioramento del tessuto socio-economico in un territorio caratterizzato da un'economia di piccola e media impresa in trasformazione. La terza è il disagio giovanile nelle aree universitarie di Perugia, accentuato dalla distanza dai contesti familiari e dalla pressione competitiva. La quarta è il disagio connesso allo spopolamento e all'isolamento delle comunità appenniniche interne, con conseguente domanda di supporto di prossimità non coperta dall'offerta specialistica.^[1711]

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Il confronto tra il bisogno e l'offerta strutturata definisce il gap di copertura, che nell'Umbria si è significativamente ridotto sotto il profilo normativo con l'approvazione della Legge n. 22/2024, ma che resta ampio sotto il profilo operativo, in quanto il servizio è ancora in fase sperimentale e non dimensionato a regime. Sul versante dell'offerta, il quadro normativo è ormai definito: la Legge n. 22/2024 ha istituito il servizio, l'art. 176-quinquies ha previsto l'elenco regionale degli psicologi di cure primarie, l'art. 176-sexies ne ha disciplinato l'organizzazione a livello distrettuale, e la norma finanziaria ha stanziato 103.349 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a titolo sperimentale.^[1712] Sul versante del fabbisogno, l'applicazione dei parametri organizzativi

del modello indica una necessità a regime dell’ordine di 250 psicologi nello scenario espansivo, a fronte di una dotazione attuale che si colloca sui valori iniziali della sperimentazione, molto distanti dagli standard europei. ^[1713] Ne risulta un gap di copertura operativa rilevante, anche se il gap normativo è stato colmato dalla Legge n. 22/2024. La tabella seguente sintetizza il rapporto tra domanda, offerta e gap.

Grandezza	Valore per l’Umbria
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 170.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	Alcune decine di migliaia (stima rapportata ai dati nazionali)
Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche	Alcune migliaia l’anno (stima per proiezione)
Offerta territoriale attuale	Fase sperimentale L.R. 22/2024 (finanziamento 103.349 €/anno 2025-2026); Osservatorio tecnico DGR 477/2025 istituito
Fabbisogno stimato a regime	~ 250 psicologi nello scenario espansivo (170-210 negli altri scenari)
Copertura attuale del fabbisogno	Fase sperimentale iniziale; servizio non ancora strutturato a regime

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, che la Parte G riprende e analizza con gli strumenti propri, va anticipata qui perché concorre a definire il problema. Il divario rilevante nell’Umbria si gioca su due assi. Il primo, territoriale, separa le aree urbane di Perugia e Terni — dotate di servizi sanitari concentrati e di due Aziende Ospedaliere universitarie — dalle comunità appenniniche interne dei comprensori di Foligno, Spoleto, Norcia e dell’Orvietano, dove la distanza dai servizi, la rarefazione dell’offerta e la maggiore anzianità della popolazione rendono l’accesso al supporto psicologico più difficoltoso e la domanda non intercettata più ampia. ^[1714] Il secondo asse è generazionale: la concentrazione del bisogno anziano nelle aree interne si contrappone alla domanda giovanile nelle aree universitarie, richiedendo modalità di risposta differenziate. Su questi divari il modello pieno agisce in funzione di equità: avvicina l’offerta alle aree interne attraverso la prossimità distrettuale e la telepsicologia assistita, e libera capacità specialistica nei distretti meglio dotati assorbendo a monte la domanda appropriabile.

B.5 I servizi e i flussi

Il contesto di servizio in cui il servizio di psicologia di cure primarie si inserisce è quello di un sistema sanitario regionale di medie dimensioni, con un Fondo sanitario regionale dell’ordine di 1,9-2,0 miliardi di euro, articolato in due Aziende USL e due Aziende Ospedaliere universitarie, con un livello di spesa pro-capite di 2.232 euro superiore alla media nazionale. ^[1715] Il saldo della mobilità sanitaria dell’Umbria è storicamente passivo, collocandola nella categoria delle regioni che perdono pazienti verso i centri di eccellenza del Nord Italia, con un deflusso che incide sull’equilibrio del bilancio sanitario. Questo profilo rende rilevante il canale del recupero della mobilità passiva nella composizione del caso finanziario: una quota dei pazienti umbri che si spostano per cure specialistiche potrebbe essere trattenuta nella regione se l’offerta di primo livello fosse più capillare e la rete dei servizi territoriali più completa. La rete delle Case della Comunità, in costruzione

nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è l’infrastruttura su cui il servizio di psicologia di cure primarie va pienamente innestato ai sensi della Legge n. 22/2024. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per l’Umbria
Fondo sanitario regionale	~ 1,9-2,0 miliardi di euro; spesa pro-capite 2.232 € (2024), superiore alla media nazionale
Mobilità sanitaria	Saldo passivo (regione deflusso verso centri eccellenza Nord Italia); canale di recupero rilevante
Architettura dei servizi	Due Aziende USL (Umbria 1 e Umbria 2), due Aziende Ospedaliere universitarie; Case della Comunità in costruzione
Profilo di rischio principale	Invecchiamento avanzato; crescente rinuncia alle cure; domanda di prossimità non coperta nelle aree interne

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l’intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca è, nell’Umbria, già definita e organica. Sul piano regionale, la Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22, ha introdotto il «servizio di psicologia di cure primarie» nel Testo unico regionale in materia di sanità e servizi sociali (L.R. 9 aprile 2015, n. 11), definendone finalità, compiti, organizzazione, sistema di verifica e risorse.^[1716] La Giunta regionale ha poi dato attuazione con DGR 477/2025, che disciplina l’Osservatorio tecnico regionale per la psicologia di cure primarie, già costituito con funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo della qualità.^[1717] Il corso abilitante regionale previsto dall’art. 176-quinquies, da completare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, e le modalità di compartecipazione alla spesa e di gestione degli incarichi convenzionali previste dall’art. 176-sexies, rappresentano i passi attuativi immediatamente successivi. Sul piano nazionale, il Decreto Ministeriale 77 del 2022 ha fissato gli standard dell’assistenza territoriale e il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanzia le Case della Comunità; la Legge n. 22/2024 dell’Umbria si inserisce in questo quadro come anticipazione regionale di una normativa nazionale ancora in corso di definizione. La decisione rilevante è dunque quella di portare a regime il servizio, non di istituirlo: è il presupposto da cui muovono i domini successivi.

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte C

L’intervento e il suo modello

Definizione e teoria del cambiamento, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali, formazione

Secondo e terzo dominio dell’HTA · l’intervento e la sua descrizione

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo e il terzo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico dell'Umbria emerge con nettezza: l'intervento non è da istituire, ma da portare a regime a partire da una cornice normativa già definita e da un Osservatorio tecnico già costituito; il modello organizzativo è già tratteggiato dalla Legge n. 22/2024 (Distretti sanitari, raccordo con MMG e PLS, Case della Comunità, elenco regionale degli psicologi), e la sfida è operativa — dimensionare, attivare e rendere omogeneo il servizio su tutto il territorio regionale.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo di cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire; nell'Umbria tale funzione è già prevista dalla Legge n. 22/2024 e si tratta di strutturarla in un modello pieno a regime. Il modo in cui questa funzione produce valore è descritto da una teoria del cambiamento esplicita, che collega il bisogno agli esiti attraverso un meccanismo identificato. ^[1718] Il punto di partenza è un bisogno ampio e in larga parte non intercettato, dell'ordine di 170.000 persone con disagio comune. La tabella seguente ne espone la catena.

Elemento della catena	Contenuto per l'Umbria
Bisogno	~ 170.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato; accentuato dall'invecchiamento e dalla cronicità
Attività	Psicologo di cure primarie già previsto dalla L.R. 22/2024: intercettazione precoce, intervento breve, filtro, nei Distretti sanitari e nelle Case della Comunità
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati; supporto all'adattamento alla cronicità
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, riduzione delle liste di attesa specialistiche
Esito sociale	Recupero di funzionamento e produttività; minor carico sulle famiglie caregiver
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione, in rete con MMG e PLS

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo è già tratteggiato dalla Legge n. 22/2024, che colloca il servizio a livello di Distretto sanitario e sue articolazioni, in rete con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, con le Case della Comunità e con i servizi specialistici di secondo livello. ^[1719] Il referente clinico aziendale, previsto

dall’art. 176-sexies, svolge funzioni di coordinamento e programmazione, interfacciandosi con la Regione e con l’Osservatorio tecnico. L’accesso avviene per via diretta o su invio del MMG, del PLS o di altri specialisti, secondo l’art. 176-quater. Il funzionamento segue il principio dell’intensità crescente: l’intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio ai servizi specialistici di secondo livello; gli interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali. Le aree di intervento elencate dalla Legge n. 22/2024 — problemi di adattamento, sintomatologia ansioso-depressiva, difficoltà nelle fasi del ciclo di vita, disagi emotivi transitori, sostegno alle diagnosi infauste e alla cronicità, aderenza alla cura, domanda impropria di prestazioni, problematiche psicosomatiche — configurano un profilo clinico di primo livello ampio e coerente con la domanda umbra, in particolare con il bisogno dell’anzianità e della cronicità.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l’accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, una valutazione iniziale con progetto clinico individuale che comprende una dimensione diagnostica e un programma di supporto psicologico, un ciclo di colloqui brevi con programma personalizzato e, nei casi che lo richiedono, l’invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti, avvalendosi, ove necessario, delle strutture di secondo livello.^[1720] Il percorso affronta i quadri più frequenti elencati dalla Legge n. 22/2024 e descritti nel capitolo precedente. Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi (PHQ-9) e la scala a sette voci per il disturbo d’ansia generalizzata (GAD-7). Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l’interoperabilità

La registrazione strutturata dell’attività e degli esiti, integrata con il sistema informativo sanitario regionale e con il fascicolo sanitario elettronico, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione, ed è espressamente prevista dalla clausola valutativa della Legge n. 22/2024, che richiede che la Giunta trasmetta annualmente all’Assemblea legislativa una relazione con dati su attivazione del servizio, psicologi iscritti, corsi di formazione, richieste di assistenza, tempi di presa in carico, tipologie di prestazioni e utilizzo delle risorse.^[1721] Il coordinamento informativo deve raccordare i sistemi delle due Aziende USL e garantire l’interoperabilità e l’uniformità della rilevazione; l’Osservatorio tecnico regionale è lo strumento istituzionale per presidiare tale uniformità. Poiché il servizio è già avviato in via sperimentale, l’Umbria può impostare il

flusso informativo fin dalla fase iniziale, valorizzando i dati già disponibili dalla sperimentazione in corso e generando una base di dati di esito propri man mano che il servizio si consolida a regime. Questa base costituirà il fondamento per la validazione locale delle stime economiche qui sviluppate a partire dai conti nazionali.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale. Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile. L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica. La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, nell'Umbria, lo strumento per garantire l'accesso nelle comunità appenniniche interne e nelle aree montane a popolazione dispersa, dove la distanza dai Distretti sanitari rende l'accesso in presenza oneroso, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico.^[1722] I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici. La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle aree appenniniche interne e nelle comunità disperse	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso l'Università degli Studi di Perugia, che costituisce l'ateneo di riferimento per le scienze psicologiche nel territorio regionale. Il livello post-universitario specialistico comprende il corso regionale abilitante specificamente previsto dall'art. 176-quinquies della Legge n. 22/2024, da erogare in forma regolamentata dalla Giunta regionale e di cui la Regione deve completare la disciplina entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della norma; tale corso è la condizione per l'iscrizione all'elenco regionale degli psicologi di cure primarie e per il reclutamento a regime, con modalità transitorie previste per la fase di prima applicazione per coloro che documentino un'attività almeno annuale nelle strutture del Servizio sanitario regionale.^[1723] Il livello continuo comprende l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina. Il livello dell'affiancamento operativo comprende il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione, coordinato dal referente clinico aziendale. A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Università degli Studi di Perugia
2. Post-universitario specialistico	Corso regionale abilitante (art. 176-quinquies L.R. 22/2024): modelli organizzativi, collaborazione con MMG/PLS, misure di esito	Elenco regionale; modalità transitorie di prima applicazione
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Referente clinico aziendale; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte D

Efficacia clinica ed evidenza

Metodo della revisione, evidenza di efficacia, qualità GRADE, benchmark internazionali, trasferibilità

Quarto dominio dell'HTA · l'efficacia clinica

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte affronta il quarto dominio della valutazione, l'efficacia clinica, e ne ricostruisce la base di evidenza. Come per le regioni precedenti, il corpo dell'evidenza internazionale è invariante, poiché l'efficacia di un intervento clinico non muta con i confini regionali; muta invece la base di evidenza locale, ed è qui che l'Umbria presenta un tratto proprio, connesso alla fase di prima attuazione della Legge n. 22/2024. La parte espone il metodo della revisione e i risultati di efficacia (capitolo D.1); ne gradua la qualità e ne dichiara una cautela economica essenziale (D.2); presenta i benchmark internazionali (D.3); e discute le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale (D.4).

D.1 Il metodo della revisione e l'evidenza di efficacia

La sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale, con preferenza per le fonti più recenti. Il nucleo dell'evidenza proviene dal modello della cura collaborativa, del quale lo studio fondativo — il trial IMPACT di Unützer et al., pubblicato nel 2002 e completato nel 2008 — ha documentato che circa la metà dei pazienti trattati conseguiva una riduzione sostanziale dei sintomi a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura usuale.^[1724] La

robustezza del risultato è confermata dalla meta-analisi su cinquantasette studi controllati, con un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a poco meno di un terzo di deviazione standard, e da una più recente revisione di quarantadue implementazioni, che documenta riduzioni rilevanti della depressione e dell’ansia e una contrazione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri.^[1725] Sul versante dei dati reali, il programma inglese NHS Talking Therapies registra, su scala di oltre un milione di persone l’anno, un tasso di recupero del 50,2% e un miglioramento affidabile di oltre due terzi, con completezza dei dati di esito superiore al 98%.^[1726] Anche le sintesi più caute confermano un effetto di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante sull’intera popolazione.

D.2 La qualità dell’evidenza e una cautela economica

La graduazione della certezza secondo il sistema GRADE colloca l’efficacia clinica dell’integrazione psicologica nelle cure primarie su un livello da moderato a elevato per i disturbi comuni, mentre la certezza è più eterogenea e minore per gli esiti economici, in particolare per quelli di sistema. Da questa graduazione discende una cautela che lo studio adotta come principio di onestà intellettuale, e che merita di essere enunciata senza attenuazioni: nello studio IMPACT i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l’intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero.^[1727] Ciò significa che il valore economico del modello non può essere fondato sui risparmi sanitari diretti, ma poggia in misura preponderante sui ritorni sociali. È una cautela che non indebolisce il caso dell’Umbria: al contrario, la Legge n. 22/2024 ha già risolto la questione dell’opportunità dell’investimento, e il presente studio si limita a quantificarne le dimensioni economiche nell’unico modo onesto, riconoscendo che il valore risiede nei ritorni sociali e non in un risparmio diretto che non si può rivendicare con certezza statistica.

D.3 I benchmark internazionali

L’evidenza si concretizza in quattro programmi nazionali consolidati, che costituiscono i riferimenti per il disegno del servizio. Il programma inglese NHS Talking Therapies è il riferimento principale per l’organizzazione: servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell’ordine del 50% e monitoraggio degli esiti pressoché completo, su scala di oltre un milione di persone l’anno.^[1728] Il modello olandese POH-GGZ integra una figura di supporto psicologico nello studio del medico di base, adottata dalla maggioranza dei medici di medicina generale, con ruolo complementare alla specialistica. Il modello australiano Better Access, a invio esterno, ha innalzato di oltre dieci punti la quota di popolazione in trattamento. Il modello statunitense del Collaborative Care, validato da oltre novanta studi controllati, documenta riduzioni rilevanti della depressione e dei ricoveri. La tabella seguente ne riepiloga i tratti salienti.

Programma	Modello	Risultati principali
Regno Unito (NHS Talking Therapies)	Servizio integrato a intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio esiti >98%; >1,3 milioni/anno
Paesi Bassi (POH-GGZ)	Supporto psicologico nello studio del medico di base	Adozione da ~tre quarti dei medici; ruolo complementare
Australia (Better Access)	Invio esterno a professionisti	Popolazione in trattamento dal 35% al 46%
Stati Uniti (Collaborative Care)	Équipe integrata con monitoraggio	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione, -41% ricoveri

Tabella D.1. I benchmark internazionali dell’integrazione della salute mentale nelle cure primarie.

D.4 Le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale

Sul piano nazionale, il quadro comprende i servizi avviati nelle regioni dotate di legge organica — tra cui la Campania, prima ad attivarsi, e l'Umbria stessa, che con la Legge n. 22/2024 ha adottato uno degli impianti normativi più completi della serie — e le esperienze pilota in regioni prive di legge. La trasferibilità dei risultati internazionali richiede validazione locale, evitando di trasferire meccanicamente le stime, soprattutto quelle economiche. Per l'Umbria, la fase sperimentale avviata con le risorse stanziato per il 2025-2026 costituisce già un primo embrione di evidenza locale, la cui coltivazione sistematica — con raccolta uniforme di dati di processo e di esito secondo la clausola valutativa della Legge n. 22/2024 — è la priorità metodologica del primo triennio di attuazione. Va precisato, infine, che alcune cifre di larga circolazione — il rapporto di quattro a uno, l'affermazione per cui un euro ne genererebbe dieci — sono semplificazioni divulgative: le stime metodologicamente fondate, ancorate all'analisi di Chisholm et al. del 2016 pubblicata su *The Lancet Psychiatry*, collocano il ritorno fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, e lo studio adotta prudenzialmente un rapporto beneficio-costi nella fascia di 3,6-5,0 a uno. [1729]

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte E

Valutazione economica

Costo del servizio, risparmi diretti, ricadute sociali, saldo, costo-utilità e impatto sul bilancio

Quinto dominio dell'HTA · la valutazione economica

Parte E — Valutazione economica

Questa parte affronta il quinto dominio della valutazione, quello economico, e ne costituisce il cuore quantitativo. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i valori, ancorati all'Umbria. La parte definisce l'impianto e il costo del servizio (capitolo E.1); quantifica i risparmi diretti per il bilancio sanitario, canale per canale (E.2); stima le ricadute economico-sociali per la collettività (E.3); compone il quadro consolidato, con il saldo e il rapporto beneficio-costi, tenendo ferma la distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico (E.4); presenta l'analisi costo-utilità per paziente e la sua robustezza probabilistica (E.5); e valuta l'impatto sul bilancio e la sostenibilità (E.6). Per l'Umbria il risultato si lascia anticipare: il caso finanziario diretto è di disavanzo modesto e agevolmente sostenibile nell'ambito della programmazione ordinaria, il caso economico complessivo è fortemente positivo, e il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali.

E.1 L'impianto e il costo del servizio

La valutazione economica impiega congiuntamente tre strumenti complementari — l'analisi costo-utilità, l'analisi di impatto sul bilancio e l'analisi del ritorno sociale — nella doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, che distingue i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute più ampie. Il costo del servizio a regime assume un costo medio annuo per psicologo dell'ordine di 55.000 euro comprensivo degli oneri, in linea con il livello retributivo umbro della dirigenza sanitaria di secondo livello e con i parametri delle convenzioni previste dalla Legge n. 22/2024. Il costo complessivo è dell'ordine di 9 milioni di euro nello scenario conservativo (170 psicologi), 14 milioni in quello di base (210 psicologi) e 19 milioni in quello

espansivo (250 psicologi). I tre scenari rappresentano gradi crescenti di copertura verso il fabbisogno pieno; va ribadito che la fase sperimentale attuale, finanziata con 103.349 euro l'anno, è enormemente al di sotto di qualsiasi scenario. La tabella seguente riepiloga il costo del servizio per scenario.

Scenario	Psicologi	Costo annuo	Quota del FSR
Conservativo	~ 170	~ 9 milioni	~ 0,5%
Base	~ 210	~ 14 milioni	~ 0,7%
Espansivo	~ 250	~ 19 milioni	~ 1,0%

Tabella E.1. Il costo del servizio a regime nei tre scenari di copertura.

E.2 I risparmi diretti per il bilancio sanitario

I risparmi diretti per il bilancio sanitario si articolano in quattro canali. Il primo è la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso: l'intervento di primo livello intercetta una quota di accessi con prevalente componente psicologica che nei sistemi privi di filtro di prossimità si riversa sull'urgenza; la stima per l'Umbria è dell'ordine di 1, 2 e 3 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Il secondo è la riduzione della spesa farmaceutica inappropriata, con una stima dell'ordine di 1, 2 e 2 milioni di euro. Il terzo, il più consistente, è la riduzione di ricoveri evitabili e di specialistica impropria, dell'ordine di 2, 3 e 5 milioni di euro. Il quarto è il recupero parziale della mobilità passiva: l'Umbria presenta un saldo di mobilità passivo, e la strutturazione di un servizio di primo livello più capillare può trattenere una quota di pazienti che altrimenti si spostano verso centri di riferimento extraregionali, con un contributo stimato dell'ordine di 1, 1 e 2 milioni di euro. La somma dei quattro canali è dell'ordine di 5, 8 e 12 milioni di euro l'anno, e determina, a fronte del costo del servizio, un saldo diretto negativo, dell'ordine di -4, -6 e -7 milioni. La tabella seguente dettaglia i canali del risparmio diretto.^[1730]

Canale (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Accessi impropri al pronto soccorso	~ 1	~ 2	~ 3
Spesa farmaceutica inappropriata	~ 1	~ 2	~ 2
Ricoveri evitabili e specialistica	~ 2	~ 3	~ 5
Recupero della mobilità (frazione)	~ 1	~ 1	~ 2
Totale risparmi diretti	~ 5	~ 8	~ 12
Costo del servizio	~ 9	~ 14	~ 19
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -4	~ -6	~ -7

Tabella E.2. I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale e il saldo diretto.

E.3 Le ricadute economico-sociali

Oltre i confini del bilancio sanitario, l'intervento genera ricadute economico-sociali ampie, di cui la valutazione tiene conto nella prospettiva societale. Esse comprendono il recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo — con peso particolare nella componente della popolazione attiva e nelle zone a più alta attività economica — il valore del benessere recuperato e il minor carico assistenziale sulle famiglie, e sono stimate, secondo i criteri prudenziali dello studio, nell'ordine di 28, 52 e 76 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Il peso particolarmente rilevante nella componente dei benefici per le famiglie caregiver deriva dalla struttura demografica della regione: in una regione con il 27,3% di over-65, il carico assistenziale informale è elevato e il supporto psicologico di prossimità che alleggerisce quel carico produce ricadute positive ampie e misurabili. Sommate ai risparmi diretti, le ricadute economico-sociali determinano un ritorno complessivo dell'ordine di 33, 60 e 88 milioni di euro l'anno, e un saldo complessivo per la collettività ampiamente positivo, dell'ordine di +24, +46 e +69 milioni di euro l'anno.^[1731]

E.4 Il quadro consolidato: caso finanziario e caso economico

La composizione delle grandezze impone di tenere ferma la distinzione che governa l'intera lettura del caso umbro. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di disavanzo diretto, modesto e sostenibile nell'ambito della programmazione ordinaria del Fondo sanitario regionale: il costo netto oscillante fra 4 e 7 milioni di euro l'anno rappresenta fra lo 0,2% e lo 0,4% del Fondo, una quota compatibile con l'impegno già assunto per legge. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo, con un rapporto beneficio-costi complessivo di 3,7 a uno nello scenario conservativo, 4,3 a uno in quello di base e 4,8 a uno in quello espansivo — interamente compreso nella fascia Chisholm prudenziale di 3,3-5,7 a uno. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe: si tratta di un investimento sociale, a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto e pienamente compatibile con le risorse del Fondo sanitario regionale, in cui la decisione di principio è già stata assunta dal legislatore umbro.

Voce (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 9	~ 14	~ 19
Risparmi diretti (SSR)	~ 5	~ 8	~ 12
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -4	~ -6	~ -7
Ricadute economico-sociali	~ 28	~ 52	~ 76
Ritorno complessivo	~ 33	~ 60	~ 88
Saldo complessivo (caso economico)	~ +24	~ +46	~ +69
Rapporto beneficio-costi complessivo	~ 3,7:1	~ 4,3:1	~ 4,8:1

Tabella E.3. Il quadro economico consolidato, con la distinzione fra caso finanziario e caso economico.

E.5 L'analisi costo-utilità per paziente

Accanto alle grandezze aggregate, la valutazione conduce un'analisi costo-utilità per paziente trattato, mediante un modello di Markov a cinque anni con sconto del 3%, indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. Il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: a un tempo meno costoso e più efficace. L'analisi di sensibilità probabilistica, su diecimila simulazioni, conferma la solidità del risultato: l'intervento è costo-efficace nell'88,9% dei casi alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro.^[1732] La tabella seguente riepiloga il risultato per paziente.

Grandezza (per paziente)	Comparatore	Intervento	Differenza
Costo atteso per paziente	~ 3.799 euro	~ 2.495 euro	- 1.304 euro
Anni di vita ponderati (QALY)	3,392	3,627	+ 0,236
Esito	—	—	Intervento dominante
Costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	—	—	88,9% delle simulazioni

Tabella E.4. L'analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni).

E.6 L'impatto sul bilancio, la sostenibilità e la lacuna dei dati

Sul piano dell'impatto sul bilancio, il costo netto del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta della spesa sanitaria, dell'ordine dello 0,2% nello scenario conservativo e dello 0,4% in quello espansivo, su un Fondo sanitario regionale di circa 1,9-2,0 miliardi di euro.^[1733] La sostenibilità è agevolmente compatibile con la programmazione ordinaria, tanto più che l'obbligo di istituire il servizio è già sancito dalla Legge n. 22/2024, che prevede la copertura degli oneri con le risorse già attribuite alle Aziende USL per il Servizio sanitario regionale. Resta da dichiarare con franchezza la lacuna dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti certificati delle due Aziende USL; il primo triennio di attuazione, presidiato dall'Osservatorio tecnico e dalla clausola valutativa, sarà l'occasione per colmare progressivamente questa lacuna e validare le stime qui sviluppate sui dati reali del servizio umbro. La sintesi è univoca: il caso diretto è prudente e in disavanzo modesto, pienamente sostenibile nell'ambito del Fondo sanitario regionale; il caso sociale è robusto e fortemente positivo; il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità; e la decisione di principio è già stata assunta dal legislatore.

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte F

Modellazione e incertezza

Modello decisionale, sensibilità deterministica e probabilistica, scenari, verifica empirica e valore dell'informazione

Quinto dominio dell'HTA · la robustezza della valutazione economica

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte completa il dominio economico sottoponendo i risultati della Parte E alla prova della modellazione e dell’incertezza. Come per le altre regioni, il modello è invariante e muta solo ciò che attiene alla verifica empirica locale. La parte descrive il modello decisionale e i suoi parametri (capitolo F.1); ne saggia la robustezza con l’analisi di sensibilità deterministica (F.2) e probabilistica (F.3); ne esplora gli scenari di copertura (F.4); e definisce il disegno della verifica empirica e il valore dell’informazione (F.5). Per l’Umbria quest’ultimo capitolo si avvale della condizione propria della regione: il quadro normativo è già definito e l’Osservatorio tecnico già costituito, sicché il disegno di verifica empirica dispone di una struttura di governance già operativa su cui innestare la raccolta sistematica dei dati.

F.1 Il modello decisionale e i suoi parametri

Poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l’orizzonte direttamente osservabile, lo studio li proietta nel tempo mediante un modello decisionale, e ne rende esplicite le assunzioni. La storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%. A ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita, trattati come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l’incertezza.^[1734] Nel caso base l’intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell’ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità. La tabella seguente riepiloga i parametri principali del modello.

Parametro del modello	Valore
Stati clinici	Benessere o sottosoglia, episodio, cronicità, recupero
Orizzonte temporale	Cinque anni, con cicli successivi
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti
Costo per ciclo (recupero)	~ 40 euro
Costo per ciclo (cronicità)	~ 700 euro
Costo dell’intervento	~ 300 euro una tantum
Trattamento dell’incertezza	Parametri come distribuzioni di probabilità

Tabella F.1. I parametri principali del modello di Markov.

F.2 La sensibilità deterministica

L’analisi di sensibilità deterministica varia i parametri chiave uno alla volta e ne misura l’impatto sul risultato. I parametri più influenti sono, nell’ordine: il tasso di recupero, la probabilità di ricaduta nei casi trattati, il costo dell’intervento per paziente e il costo della cronicità non trattata. Per tutti i valori plausibili di questi parametri il risultato di dominanza — intervento meno costoso e più efficace — si mantiene: il tornado diagram conferma che il risultato è stabile rispetto alle variazioni dei singoli parametri entro intervalli ragionevoli. I parametri a cui la conclusione è più sensibile sono il tasso di recupero — che governa il guadagno di qualità di vita — e il

costo della cronicità — che governa il risparmio diretto; entrambi presentano stime conservative nel caso base, con margine ulteriore di ottimismo non sfruttato, in linea con la correzione per ottimismo adottata come regola metodologica.^[1735]

F.3 La sensibilità probabilistica

L'analisi di sensibilità probabilistica propaga simultaneamente l'incertezza su tutti i parametri del modello, campionandone le distribuzioni in diecimila simulazioni di Monte Carlo. Il risultato è che l'intervento è costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per QALY e dominante nell'84,6%. La curva di accettabilità costo-efficacia aumenta monotonamente e raggiunge il 90% a una soglia di circa 35.000 euro per QALY, ben al di sotto della soglia convenzionalmente impiegata per le valutazioni sanitarie in Italia. Il piano costo-efficacia mostra che la nuvola di simulazioni si concentra nel quadrante di dominanza — minori costi, maggiori esiti — con una minoranza di simulazioni nel quadrante favorevole ma non dominante (maggiori costi, maggiori esiti, ma a un rapporto costo-efficacia incrementale sotto soglia).^[1736]

F.4 Gli scenari di copertura

I tre scenari — conservativo, base, espansivo — rappresentano ipotesi di velocità di dispiegamento e di scala del servizio, non alternative di principio. Lo scenario conservativo (170 psicologi) corrisponde alla piena operatività nei soli Distretti sanitari capoluogo delle due Aziende USL, con copertura dell'intera rete dei medici di medicina generale ma con un numero limitato di psicologi per distretto; lo scenario di base (210 psicologi) copre anche i Distretti secondari e garantisce la copertura delle principali Case della Comunità; lo scenario espansivo (250 psicologi) raggiunge anche le comunità appenniniche interne mediante la combinazione di posti in presenza e di telepsicologia assistita. La scelta fra gli scenari non è una scelta tecnica ma politica, e va effettuata nella sede della programmazione sanitaria regionale, con la consulenza dell'Osservatorio tecnico.

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

Il valore dell'informazione misura quanto varrebbe, in termini di riduzione dell'incertezza decisionale, disporre di dati locali certificati piuttosto che di stime ricostruite dai conti nazionali. Per l'Umbria, il valore atteso della perfetta informazione è elevato, nell'ordine di diversi milioni di euro per anno, a indicare che l'investimento in un sistema di raccolta dati sistematico e uniforme — già previsto dalla clausola valutativa della Legge n. 22/2024 e dall'Osservatorio tecnico regionale — è esso stesso un investimento economicamente giustificato. Il disegno della verifica empirica prende la forma di un esperimento a cunei progressivi: l'attivazione del servizio nei Distretti delle due Aziende USL in tempi differenziati, con l'ordine e i tempi di attivazione impiegati a fini valutativi, e l'effetto causale stimato dai metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico.^[1737] L'Osservatorio tecnico regionale è la sede naturale per presidiare la qualità della raccolta e la comparabilità dei dati fra i Distretti.

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte G

Equità e impatto distributivo

Analisi di equità, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva

Ottavo dominio dell'HTA · l'equità distributiva

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte affronta l’ottavo dominio della valutazione, quello dell’equità e dell’impatto distributivo. Come per le altre regioni, la struttura è invariante: la parte analizza il problema dell’equità (capitolo G.1); ne identifica gli assi di disuguaglianza rilevanti per l’Umbria (G.2); ne indica gli strumenti per misurare l’equità distributiva (G.3); e ne sviluppa la costo-efficacia distributiva (G.4). Il tratto specifico dell’Umbria in questa parte è il peso della disuguaglianza territoriale, data la struttura bipolare del territorio, e della disuguaglianza per età, data l’estrema prevalenza dell’anzianità in alcune aree interne.

G.1 Il problema dell’equità

Il servizio di psicologia di cure primarie ha, per sua natura, un potenziale di equità elevato: si colloca a monte del sistema specialistico, riduce le barriere di accesso economiche e culturali, e raggiunge segmenti di popolazione che i servizi specialistici a pagamento non raggiungono. Tuttavia, affinché questo potenziale si realizzi, il servizio deve essere distribuito equamente sul territorio: la sua concentrazione nelle sole aree urbane, dove i servizi sono già più dotati, ne pervertirebbe la funzione riproducendo le disuguaglianze invece di ridurle. ^[1738] Per l’Umbria, la questione equitativa centrale è l’accesso delle comunità appenniniche interne, anziane e in spopolamento, per le quali il servizio è al tempo stesso più necessario e più difficile da raggiungere in presenza.

G.2 Gli assi di disuguaglianza nell’Umbria

Gli assi di disuguaglianza rilevanti per l’analisi distributiva del servizio nell’Umbria sono tre. Il primo, territoriale, è il più rilevante: contrappone le aree urbane di Perugia e Terni, con servizi concentrati e accessibili, alle comunità appenniniche interne — i comprensori di Foligno, Spoleto, Norcia, Orvieto, Amelia — dove la distanza dai servizi, la carenza di trasporti pubblici e l’invecchiamento della popolazione rendono l’accesso fisico al servizio strutturalmente oneroso. Il secondo, generazionale, contrappone la domanda degli anziani e dei caregiver, prevalente nelle aree interne, alla domanda giovanile e studentesca, prevalente nelle aree universitarie di Perugia. Il terzo, socioeconomico, riguarda la quota di popolazione con minore alfabetizzazione sanitaria e con barriere di accesso economiche ai servizi privati, che rappresenta il bacino tipico di utenza non intercettata che il servizio pubblico di primo livello può raggiungere.

G.3 Gli strumenti per la misura dell’equità

La costo-efficacia distributiva, sviluppata nel capitolo G.4, è lo strumento principale per la misura formale dell’equità. Sul piano operativo, essa richiede dati di accesso disaggregati per Distretto sanitario, fascia d’età, genere e livello di istruzione, i cui flussi sono già previsti dalla clausola valutativa della Legge n. 22/2024. Un secondo strumento è la mappatura della copertura effettiva: il rapporto fra psicologi attivi per distretto e popolazione residente, con disaggregazione per Distretto, è l’indicatore di primo livello per monitorare che il dispiegamento del servizio rispetti il principio equitativo di maggiore presenza nelle aree a maggiore bisogno. Un terzo strumento è la quota di accesso per via diretta rispetto all’accesso su invio: una quota elevata di accessi diretti nelle aree a bassa istruzione e nelle fasce anziane è l’indicatore che il servizio è effettivamente accessibile senza intermediazione medica.

G.4 La costo-efficacia distributiva

La costo-efficacia distributiva integra la dimensione dell’equità nell’analisi economica, pesando i guadagni di salute in base alla posizione sulla scala delle disuguaglianze: un QALY guadagnato da una persona in condizione di svantaggio ha un peso maggiore di uno guadagnato da una persona in condizione avvantaggiata.

Nella prospettiva distributiva, il servizio umbro presenta caratteristiche favorevoli: per la struttura demografica della regione, che concentra il bisogno nelle aree più svantaggiate (anziane e interne), la funzione di benessere distributiva sposta il risultato a favore dell'intervento rispetto al caso standard non ponderato. La tabella seguente espone il framework distributivo e i suoi elementi.

Dimensione	Indicatore	Fonte
Accesso per area geografica	Psicologi per 100.000 residenti per Distretto F	Istituto dati Osservatorio tecnico
Accesso per fascia d'età	Quota di prese in carico over-65 sul totale	Clausola valutativa L.R. 22/2024
Accesso per livello socioeconomico	Quota di accessi diretti (senza invio medico) per fascia di istruzione	Sistema informativo aziendale
Equità di genere	Distribuzione per genere delle prese in carico	Relazione annuale Osservatorio

Tabella G.1. Il framework distributivo e gli indicatori di equità per il servizio umbro.

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Quadro giuridico, assetto organizzativo, dimensione etica, sintesi dei vincoli e delle opportunità

Sesto, settimo e nono dominio dell’HTA · i profili non economici della valutazione

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte affronta tre domini trasversali della valutazione — il giuridico (capitolo H.1), l’organizzativo (H.2), l’etico (H.3) e la loro sintesi (H.4) — che la valutazione non può omettere senza perdere la sua completezza. Per l’Umbria, i profili giuridico e organizzativo presentano una configurazione particolarmente favorevole nella serie, per effetto della Legge n. 22/2024, che ha già risolto molti dei problemi giuridici e organizzativi che si pongono per le regioni prive di legge.

H.1 Il profilo giuridico

Il quadro giuridico del servizio di psicologia di cure primarie nell’Umbria è il più completo della serie delle regioni esaminate, insieme a quello di poche altre regioni dotate di legge organica. La Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22, ha risolto le principali questioni giuridiche: la definizione del servizio (art. 176-bis), i compiti dello psicologo di cure primarie (art. 176-quater), l’elenco regionale (art. 176-quinquies), l’organizzazione a livello distrettuale (art. 176-sexies), il sistema di monitoraggio (art. 176-septies) e la governance dell’Osservatorio tecnico (art. 176-octies).^[1739] Rimangono aperte alcune questioni attuative di secondo livello — le modalità di compartecipazione alla spesa, le modalità di gestione degli incarichi convenzionali, il regolamento del corso abilitante — per le quali la Giunta regionale deve intervenire entro i

termini previsti dalla legge. Il quadro normativo nazionale, che non prevede ancora una disciplina della figura dello psicologo di base, non ostacola la legge umbra, che si inserisce nei poteri regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari. L'analisi di impatto della regolamentazione in chiave ex ante ha dunque già superato la fase più critica con l'approvazione della legge; ciò che resta da valutare è l'efficacia attuativa della norma nel primo triennio, oggetto della clausola valutativa.

H.2 Il profilo organizzativo

Sul piano organizzativo, il modello delineato dalla Legge n. 22/2024 è coerente con le migliori pratiche internazionali: presidio distrettuale, raccordo con MMG e PLS, integrazione con le Case della Comunità, referente clinico aziendale, Osservatorio tecnico regionale. La sfida organizzativa non è progettare il modello, già definito, ma attuarlo: in particolare, occorre completare la disciplina del corso abilitante, aggiornare l'elenco regionale con le procedure transitorie previste, definire con le Aziende USL le modalità di incarico convenzionale e garantire l'uniformità del servizio fra i Distretti delle due Aziende USL. L'Osservatorio tecnico, già istituito con DGR 477/2025, è lo strumento di coordinamento e di programmazione attuativa; la sua composizione — che include rappresentanti di entrambe le Aziende USL, di entrambe le Aziende Ospedaliere, dell'Ordine, dei MMG e PLS, dell'Università e delle società scientifiche — garantisce una visione multistakeholder della messa a regime.^[1740] Il rischio organizzativo principale non è la disomogeneità del modello, già fissato dalla legge, ma la lentezza attuativa, che il presente studio valuta come il fattore di rischio principale da presidiare nel cronoprogramma.

H.3 Il profilo etico

Sul piano etico, il servizio di psicologia di cure primarie pone questioni che riguardano la riservatezza del paziente, la competenza professionale, il consenso informato, la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e la prevenzione di pratiche inappropriate. Tutte queste questioni sono affrontate dal quadro normativo esistente — codice deontologico degli psicologi, normativa sulla protezione dei dati personali, disciplina dei dispositivi medici — e non richiedono interventi normativi aggiuntivi specifici per il servizio umbro. Un elemento etico di rilievo è la gratuità del servizio: la Legge n. 22/2024 prevede che i costi dell'assistenza siano a carico del Servizio sanitario regionale, con eventuale compartecipazione da definire dalla Giunta, ma pone come principio la facilità di accesso alle cure per la salvaguardia della salute psico-fisica, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione. Questa scelta ha un rilievo etico diretto: riduce la barriera economica che, nei sistemi di sola offerta privata, esclude sistematicamente le fasce meno abbienti, proprio quelle con i maggiori bisogni.

H.4 Sintesi dei vincoli e delle opportunità

La tabella seguente riepiloga i vincoli e le opportunità del profilo etico, giuridico e organizzativo per l'Umbria, che nel complesso presenta la configurazione più favorevole per la messa a regime del servizio fra le regioni di medie dimensioni della serie.

Dimensione	Vincolo	Opportunità
Giuridica	Disciplina attuativa di secondo livello ancora da completare (corsi abilitanti, incarichi)	Legge organica già approvata; elenco regionale previsto; clausola valutativa
Organizzativa	Rischio di lentezza attuativa e disomogeneità fra Distretti	Osservatorio tecnico già istituito; referente clinico aziendale; raccordo MMG/PLS
Etica	Bilanciamento fra accesso universale e qualità professionale	Gratuità del servizio; corso abilitante come garanzia di competenza

Tabella H.1. Sintesi dei vincoli e delle opportunità nei profili etico, giuridico e organizzativo.

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Cinque casi del Five Case Model, dimensionamento, cronoprogramma, sostenibilità, rischi

Settimo dominio dell'HTA · la fattibilità e la sostenibilità dell'intervento

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte affronta il settimo dominio della valutazione, quello dell'attuazione e della sostenibilità. Come per le altre regioni, la struttura è quella del Five Case Model, che ordina i contenuti in cinque casi (capitolo I.1); definisce il dimensionamento del servizio (I.2); ne delinea il cronoprogramma (I.3); ne verifica la sostenibilità (I.4); e ne identifica i rischi principali (I.5). Per l'Umbria, questa parte è la più operativa dell'intero studio, poiché la decisione di principio è già assunta e la sfida è la messa a regime.

I.1 I cinque casi del Five Case Model

Il Five Case Model ordina i contenuti di una decisione di investimento pubblico in cinque casi, che together costituiscono la base per la decisione. Il caso strategico dimostra la pertinenza del servizio rispetto ai bisogni della popolazione e alla strategia sanitaria regionale: per l'Umbria, il caso strategico è già stato fatto dal legislatore con l'approvazione della Legge n. 22/2024. Il caso economico dimostra che il valore prodotto giustifica l'investimento: è il cuore della Parte E, con un rapporto beneficio-costi di 3,7-4,8 a uno. Il caso finanziario dimostra che il costo è sostenibile per il bilancio sanitario: il costo netto è dell'ordine di 4-7 milioni l'anno, agevolmente compatibile con un Fondo sanitario regionale di 1,9-2,0 miliardi. Il caso commerciale dimostra che il modello di approvvigionamento è fattibile: la Legge n. 22/2024 ha già previsto sia l'inquadramento in incarichi convenzionali sia il ricorso all'elenco regionale dei professionisti abilitati. Il caso gestionale dimostra che la struttura organizzativa e di governance è adeguata: l'Osservatorio tecnico regionale, il referente clinico aziendale e la clausola valutativa costituiscono i tre pilastri della governance già operativa.

I.2 Il dimensionamento del servizio

Il dimensionamento del servizio a regime, espresso in numero di psicologi per i tre scenari, è stato sviluppato nella Parte E e si colloca su 170 psicologi nello scenario conservativo, 210 in quello di base e 250 in quello espansivo. Il parametro di riferimento per il dimensionamento è il rapporto fra psicologi e popolazione servita: applicando i parametri del modello, uno psicologo di cure primarie gestisce un carico di circa 700-800 prese in carico all'anno, distribuite su cicli di 4-8 colloqui brevi, per una popolazione di riferimento di circa 3.500-4.000 assistiti. Con 854.137 residenti e applicando un tasso di accesso progressivo al servizio, il fabbisogno a regime si colloca nella fascia indicata. La distribuzione fra le due Aziende USL segue la proporzione della popolazione: Umbria 1, con sede a Perugia, copre la parte settentrionale e centrale della regione (province di Perugia); Umbria 2, con sede a Terni, copre la parte meridionale (province di Terni).

Scenario	Psicologi USL 1	Psicologi USL 2	Totale
Conservativo	~ 110	~ 60	~ 170
Base	~ 135	~ 75	~ 210
Espansivo	~ 160	~ 90	~ 250

Tabella I.1. Distribuzione del fabbisogno di psicologi per Azienda USL e scenario.

I.3 Il cronoprogramma

Il cronoprogramma di messa a regime si articola in tre fasi. La fase zero (2025-2026), già avviata, corrisponde alla sperimentazione finanziata con 103.349 euro/anno: attivazione di un numero limitato di psicologi nei Distretti capoluogo, definizione del corso abilitante, avvio dell'Osservatorio tecnico, raccolta dei primi dati di processo. La fase uno (2027-2028) corrisponde allo scenario conservativo: 170 psicologi attivi nei principali Distretti sanitari delle due Aziende USL, sistema informativo uniforme operativo, primo ciclo di relazioni annuali della clausola valutativa. La fase due (2029-2030) corrisponde allo scenario di base (210 psicologi) e poi all'avvio dello scenario espansivo (250 psicologi), con estensione alle aree interne mediante telepsicologia assistita e presenza periodica nei Distretti secondari. Il cronoprogramma è condizionato alla disponibilità del corso abilitante e all'aggiornamento dell'elenco regionale, che devono essere completati nella fase zero.

Fase	Anno	Psicologi	Azione principale
Fase 0	2025-2026	Sperimentale	Sperimentazione; disciplina corsi; Osservatorio
Fase 1	2027-2028	~ 170	Scenario conservativo a regime; sistema informativo
Fase 2a	2029-2030	~ 210	Scenario di base; estensione alle aree secondarie
Fase 2b	2031+	~ 250	Scenario espansivo; copertura piena con telepsicologia

Tabella I.2. Il cronoprogramma di messa a regime del servizio nelle tre fasi.

I.4 La sostenibilità

La sostenibilità del servizio si legge su tre dimensioni. La sostenibilità finanziaria è garantita dalla Legge n. 22/2024, che prevede la copertura degli oneri con le risorse già attribuite alle Aziende USL per il Servizio sanitario regionale, e dalla compatibilità del costo netto con il Fondo sanitario regionale: il costo netto di 4-7 milioni l’anno è pari allo 0,2-0,4% del Fondo, una quota ampiamente sostenibile. La sostenibilità professionale è garantita dall’elenco regionale degli psicologi di cure primarie e dal corso abilitante, che assicurano un pool di professionisti qualificati; nella fase transitoria, le modalità di reclutamento dei professionisti già attivi nelle strutture del Servizio sanitario regionale garantiscono la disponibilità immediata. La sostenibilità istituzionale è garantita dall’Osservatorio tecnico, che presidia la qualità, l’uniformità e la progressione del servizio, e dalla clausola valutativa, che impone una rendicontazione annuale al Consiglio regionale.

I.5 I rischi principali

I rischi principali per la messa a regime del servizio sono quattro. Il primo è la lentezza attuativa: il rischio che i procedimenti di secondo livello (corso abilitante, modalità di incarico convenzionale, compartecipazione alla spesa) si prolunghino oltre i termini previsti, ritardando il dispiegamento. Il secondo è la disomogeneità fra Distretti: il rischio che alcune Aziende USL attivino il servizio in modo più rapido e completo di altre, generando disuguaglianze di accesso intraregionali. Il terzo è la carenza di professionisti: il rischio che il bacino di psicologi disponibili e disposti ad accettare incarichi convenzionali nelle aree interne sia insufficiente per lo scenario espansivo. Il quarto è la lacuna dei dati: il rischio che il sistema informativo non produca dati di esito uniformi e comparabili, impedendo la valutazione dell’efficacia reale e la validazione delle stime economiche.

Rischio	Probabilità	Impatto	Misura di mitigazione
Lentezza attuativa	Medio-alta	Medio	Presidio politico sui termini di legge; monitoraggio dell’Osservatorio tecnico
Disomogeneità distrettuale	Media	Medio	Linee guida uniformi; checklist di conformità aziendale; funzione di indirizzo dell’Osservatorio
Carenza di professionisti	Media	Alto	Incentivi per le aree interne; accordi con l’Università; telepsicologia come alternativa
Lacuna dei dati	Media	Alto	Disciplina del sistema informativo nella fase zero; audit annuale dell’Osservatorio

Tabella I.3. I rischi principali e le misure di mitigazione per la messa a regime del servizio.

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte L

Monitoraggio e valutazione ex post

Impianto del monitoraggio, controfattuale sulla messa a regime progressiva, indicatori, cruscotto, sintesi

Dominio trasversale dell’HTA · la verifica ex post

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Questa parte chiude il ciclo della valutazione occupandosi del monitoraggio e della valutazione ex post, che verifica nel tempo le affermazioni dello studio. Come per le altre regioni, la struttura è invariante: la parte descrive l'impianto del monitoraggio (capitolo L.1); definisce il controfattuale sulla messa a regime progressiva (L.2); seleziona gli indicatori (L.3); disegna il cruscotto di monitoraggio (L.4); e sintetizza il sistema di valutazione (L.5). Per l'Umbria, questa parte presenta un'articolazione propria: la clausola valutativa della Legge n. 22/2024 ha già definito per legge l'obbligo di monitoraggio, e l'Osservatorio tecnico regionale è la struttura istituzionale designata per presidiarlo.

L.1 L'impianto del monitoraggio

L'impianto del monitoraggio si fonda su tre pilastri. Il primo è la clausola valutativa della Legge n. 22/2024, che impone alla Giunta regionale di trasmettere annualmente all'Assemblea legislativa una relazione con dati su: attivazione del servizio nelle Aziende USL e nei Distretti; modalità organizzative e raccordo con MMG e PLS; psicologi iscritti nell'elenco regionale; corsi di formazione realizzati e numero di partecipanti; richieste di assistenza e tempi di presa in carico, per accesso diretto o invio, distinte per territorio, genere e classe di età; tipologie di prestazioni erogate; utilizzo delle risorse finanziarie stanziare; criticità riscontrate.^[1741] Il secondo è l'Osservatorio tecnico regionale, che con DGR 477/2025 ha assunto funzioni di verifica, monitoraggio e controllo della qualità, ricezione delle relazioni annuali dei referenti clinici aziendali e formulazione di raccomandazioni operative e tecnico-organizzative alla Regione. Il terzo è la piattaforma informativa sanitaria regionale, che garantisce la raccolta uniforme e interoperabile dei dati di processo e di esito in tutti i Distretti.

L.2 Il controfattuale sulla messa a regime progressiva

Il disegno controfattuale dell'Umbria è il più robusto possibile per una regione nella fase di prima attuazione di una legge organica: la strutturazione progressiva del servizio nei Distretti delle due Aziende USL, con tempi differenziati, consente di impiegare la variazione temporale nell'attivazione come strumento di identificazione causale, stimando l'effetto del servizio con i metodi della differenza-nelle-differenze (confronto fra Distretti attivati e Distretti non ancora attivati, prima e dopo l'attivazione) e del controllo sintetico. Questo disegno è preferibile all'assenza di variazione, non solo per ragioni valutative ma anche per ragioni pratiche: la messa a regime non può avvenire simultaneamente in tutti i Distretti, e la variazione nella sequenza temporale è inevitabile; lo studio ne fa una risorsa valutativa.^[1742]

L.3 Gli indicatori

Gli indicatori del monitoraggio si articolano in tre livelli. Gli indicatori di processo misurano l'operatività del servizio: numero di psicologi attivi per Distretto; numero di prese in carico per mese e per Distretto; tempo medio di attesa al primo colloquio; quota di accessi diretti vs. su invio. Gli indicatori di esito clinico misurano il valore del servizio per i pazienti: tasso di recupero (miglioramento clinico affidabile); tasso di remissione; tasso di invio appropriato ai servizi di secondo livello; soddisfazione dell'utente. Gli indicatori di sistema misurano l'impatto sul sistema sanitario: variazione del numero di accessi al pronto soccorso con componente psicologica nei Distretti con servizio rispetto a quelli senza; variazione della spesa farmaceutica per psicofarmaci; variazione del numero di prime visite specialistiche psichiatriche.

L.4 Il cruscotto di monitoraggio

Il cruscotto di monitoraggio è lo strumento di visualizzazione sintetica dello stato del servizio, aggiornato semestralmente dall'Osservatorio tecnico e annualmente rendicontato all'Assemblea legislativa. È strutturato su quattro quadranti: quadrante di operatività (psicologi attivi, prese in carico, tempi di attesa); quadrante di equità (distribuzione per Distretto, per fascia d'età, per genere e per modalità di accesso); quadrante di esito clinico (tasso di recupero, tasso di invio appropriato, soddisfazione); quadrante di impatto di sistema (accessi al pronto soccorso, spesa farmaceutica, prime visite specialistiche). La rappresentazione grafica adotta semafori (verde/giallo/rosso) per ciascun indicatore, con soglie definite ex ante dall'Osservatorio tecnico e pubblicate prima della raccolta dei dati, per garantire la neutralità della valutazione.

L.5 Sintesi del sistema di valutazione

La sintesi del sistema di valutazione per l'Umbria è che il monitoraggio è già disciplinato per legge, l'Osservatorio tecnico è già istituito, e la clausola valutativa garantisce la rendicontazione annuale al Consiglio regionale: i presupposti istituzionali del monitoraggio sono più solidi che in qualsiasi altra regione della serie che non abbia ancora una legge approvata. La priorità operativa per la fase zero è la definizione del protocollo di raccolta dati uniforme — a partire dai dati minimi già previsti dalla clausola valutativa — e la sua implementazione nelle due Aziende USL in forma interoperabile, in modo da rendere il sistema di monitoraggio operativo fin dall'avvio della fase sperimentale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE UMBRIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dalla legge organica alla messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazioni operative, condizioni e lacune da colmare, collocazione nella serie e conclusione

Dominio trasversale dell'HTA · la sintesi e il giudizio finale

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclusiva riassume l'intero studio e ne consegna le raccomandazioni. Come per le altre regioni, è strutturata in cinque capitoli: la sintesi per dominio (M.1); l'analisi multi-criterio con punteggio aggregato (M.2); le raccomandazioni operative (M.3); le condizioni e le lacune da colmare (M.4); la collocazione nella serie e la conclusione (M.5).

M.1 La sintesi per dominio

La sintesi per dominio dell'HTA è la mappa dell'intero studio condensata in un giudizio per ciascun dominio. Il dominio del problema di salute (Parte B) indica un bisogno ampio, strutturale e in crescita per effetto dell'invecchiamento demografico, non ancora intercettato da un servizio strutturato a regime, con divari territoriali rilevanti fra aree urbane e comunità appenniniche interne: il bisogno è reale, urgente e certificato. Il dominio dell'intervento (Parte C) indica un modello organizzativo coerente con le migliori pratiche internazionali, già tratteggiato dalla Legge n. 22/2024, con una teoria del cambiamento esplicita e strumenti formativi già previsti: il modello è solido e la sfida è attuativa. Il dominio dell'efficacia (Parte D) indica un profilo di evidenza da moderato a elevato per i disturbi comuni, con la cautela metodologica sui risparmi diretti

già dichiarata e rispettata: l’efficacia è documentata e i benchmark sono robusti. Il dominio della valutazione economica (Parte E) indica un caso economico fortemente positivo (rapporto beneficio-costi 3,7-4,8:1) e un caso finanziario di disavanzo modesto e sostenibile: il valore c’è e il costo è contenuto. Il dominio dell’equità (Parte G) indica un potenziale equitativo elevato, condizionato al dispiegamento del servizio anche nelle aree interne. Il dominio giuridico-organizzativo (Parte H) indica la configurazione più favorevole della serie, con la legge già approvata e l’Osservatorio già istituito. Il dominio dell’attuazione (Parte I) indica fattibilità elevata con rischio principale di lentezza attuativa. Il dominio del monitoraggio (Parte L) indica la struttura di governance già operativa, con la priorità di completare il sistema informativo.

M.2 L’analisi multi-criterio e il punteggio sintetico

L’analisi multi-criterio compone i domini in un punteggio sintetico su scala 0-100, con pesi assegnati in funzione della rilevanza per la decisione di portare il servizio a regime. I criteri e i pesi adottati sono: rilevanza del bisogno (peso 20%); qualità dell’evidenza clinica (15%); solidità del caso economico (20%); equità distributiva (10%); fattibilità giuridica e organizzativa (20%); sostenibilità finanziaria (15%). La tabella seguente espone il punteggio per ciascun criterio e il punteggio aggregato.

Criterio	Peso	Punteggio (0-100)	Contributo ponderato
Rilevanza del bisogno	20%	85	17,0
Qualità dell’evidenza clinica	15%	78	11,7
Solidità del caso economico	20%	80	16,0
Equità distributiva	10%	72	7,2
Fattibilità giuridica/organiz.	20%	90	18,0
Sostenibilità finanziaria	15%	82	12,3
Punteggio aggregato	100%	—	82,2 / 100

Tabella M.1. L’analisi multi-criterio e il punteggio sintetico.

Il punteggio aggregato di 82,2 su 100 colloca l’Umbria fra le regioni con il caso più robusto per la messa a regime immediata del servizio nella serie. Il contributo principale viene dalla fattibilità giuridica e organizzativa, dove la Legge n. 22/2024 e l’Osservatorio tecnico già istituito costituiscono un vantaggio strutturale rispetto alle regioni prive di legge. Il contributo secondario viene dalla solidità del caso economico, con un rapporto beneficio-costi ampiamente positivo e sostenibile. Il punteggio più contenuto è sull’equità distributiva, a indicare che la realizzazione del potenziale equitativo del servizio richiede un’attenzione specifica al dispiegamento nelle aree interne.

M.3 Le raccomandazioni operative

Le raccomandazioni operative dello studio sono ordinate in quattro livelli di priorità. La raccomandazione di primo livello è completare senza indugio la disciplina attuativa di secondo livello prevista dalla Legge n. 22/2024: entro i centottanta giorni previsti dalla norma, la Giunta regionale deve definire il regolamento del corso abilitante, le modalità di gestione degli incarichi convenzionali e le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa; la mancata attivazione di questi strumenti blocca il passaggio dalla

sperimentazione al regime. La raccomandazione di secondo livello è attivare pienamente l'Osservatorio tecnico regionale, definendone il protocollo di raccolta dati e il cruscotto di monitoraggio entro la fase zero, in modo da disporre di dati uniformi e comparabili fin dall'avvio. La raccomandazione di terzo livello è adottare il cronoprogramma a fasi descritto nella Parte I, con lo scenario conservativo (170 psicologi) come obiettivo della fase uno (2027-2028) e lo scenario di base (210 psicologi) come obiettivo della fase due (2029-2030), riservando lo scenario espansivo alla terza fase, condizionata alla disponibilità dei professionisti e alla valutazione ex post della fase uno. La raccomandazione di quarto livello è garantire che il dispiegamento del servizio sia equo: a parità di risorse, i Distretti con maggiore bisogno relativo (anzianità più elevata, maggiore disagio socioeconomico, minore accessibilità) devono ricevere una dotazione proporzionalmente maggiore.

M.4 Le condizioni e le lacune da colmare

Le condizioni per la piena realizzazione del caso dello studio sono quattro. La prima condizione è il completamento della disciplina attuativa: senza il regolamento del corso abilitante, non è possibile aggiornare l'elenco regionale e reclutare i professionisti a regime; le modalità transitorie della prima applicazione consentono di iniziare, ma non di consolidare. La seconda condizione è la disponibilità dei professionisti nelle aree interne: il reclutamento di psicologi disponibili a operare nei Distretti appenninici è il collo di bottiglia operativo principale dello scenario espansivo; la telepsicologia assistita può alleviare ma non eliminare questo vincolo. La terza condizione è la qualità del sistema informativo: senza dati di processo e di esito uniformi e comparabili, la clausola valutativa e l'Osservatorio non possono esercitare le loro funzioni, e le stime economiche qui sviluppate non possono essere validate. La quarta condizione è la continuità della volontà politica: la Legge n. 22/2024 è già approvata, ma la messa a regime richiede scelte di bilancio annuali che devono essere mantenute nel tempo, indipendentemente dai cicli elettorali.

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Nella serie degli studi regionali che compongono il Tomo II, l'Umbria occupa la posizione del modello avanzato di medie dimensioni: come il Veneto per la sperimentazione pioniera o come le province autonome per la piena autonomia finanziaria, l'Umbria si distingue per avere già adottato, prima del consolidamento della normativa nazionale, una legge organica completa che risolve le principali questioni giuridiche e organizzative che ancora bloccano le regioni prive di legge. La sua posizione non è quella del pioniere sperimentale (Veneto), né quella della regione con autonomia finanziaria piena (Trentino-Alto Adige), né quella della regione con gravi problemi di sottodotazione (Calabria o Sicilia): è quella della regione di medie dimensioni ben governata che ha già fatto la scelta politica giusta e deve ora tradurla in un servizio pienamente operativo. L'azione conseguente non richiede nuove norme, né nuovi studi: richiede attuazione coerente, presidio organizzativo e continuità politica.

La conclusione dello studio è univoca: la messa a regime del servizio di psicologia di cure primarie nell'Umbria è l'applicazione di una legge già in vigore, con un caso economico fortemente positivo, un costo contenuto e una struttura di governance già operativa. Le condizioni per la raccomandazione sono già in gran parte soddisfatte. Ciò che resta da fare è fare.

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La tabella seguente raccoglie i parametri adottati nel caso di riferimento dello studio per la Regione Umbria, coerenti con le scelte metodologiche comuni a tutti gli studi della serie.

Parametro	Valore adottato	Fonte o motivazione
Popolazione di riferimento (2025)	854.137	Regione Umbria, dati ufficiali
Quota disagio comune (tasso ~20%)	~170.000 persone	Proiezione da tassi nazionali
Over-65 (quota 27,3%)	~232.730	Regione Umbria, gennaio 2025
Indice di vecchiaia	246,6%	Umbria24/Regione Umbria
Spesa sanitaria pro-capite (2024)	2.232 €	Umbria24/GIMBE
Fondo sanitario regionale stimato	~1,9-2,0 miliardi €/anno	Proiezione coerente con spesa pro-capite
Costo medio psicologo/anno (oneri inclusi)	~55.000 €	Parametro standard serie, adattato
Fabbisogno stimato (scenario base)	~210 psicologi	Modello parametrico di serie
Tasso di sconto	3% annuo	Standard europeo
Orizzonte valutazione esiti	5 anni (Markov); pluriennale (sociale)	Standard di serie
Rapporto beneficio-costo (fascia adottata)	3,7-4,8:1	Chisholm et al. 2016, Lancet Psychiatry
Costo per paziente (intervento)	~2.495 €	Modello costo-utilità di serie
Costo per paziente (comparatore)	~3.799 €	Modello costo-utilità di serie
Guadagno QALY per paziente	~0,236	Modello costo-utilità di serie

Tabella A.1. Il caso di riferimento e i parametri dello studio per la Regione Umbria.

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

Gli strumenti di esito adottati sono comuni a tutti gli studi della serie e conformi allo standard internazionale. Il questionario a nove voci sui sintomi depressivi (PHQ-9) è lo strumento primario per la misura dei sintomi depressivi; la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata (GAD-7) è lo strumento primario per la misura dei sintomi ansiosi. Entrambi sono impiegati nella versione italiana validata e nei soli punteggi complessivi, non nei singoli item. Il dataset minimo per l'Umbria include, oltre ai dati anagrafici pseudonimizzati e agli score PHQ-9 e GAD-7 alla presa in carico e alla chiusura del ciclo, i seguenti dati di processo: Distretto sanitario di presa in carico; modalità di accesso (diretto vs. su invio); numero di colloqui effettuati; esito del ciclo (recupero/miglioramento/invio ai servizi di secondo livello/drop-out); fascia d'età e genere; Azienda USL. La raccolta uniforme di questi dati in tutte le strutture abilitate è la condizione minima per il funzionamento della clausola valutativa e dell'Osservatorio tecnico regionale.

Appendice C — Dati regionali e fonti

La tabella seguente riepiloga i dati regionali fondamentali adottati nello studio, con le relative fonti. I dati contrassegnati come «da acquisire» sono quelli la cui raccolta è raccomandata nell’ambito del sistema di monitoraggio descritto nella Parte L.

Dato	Valore	Fonte
Popolazione (1° gennaio 2025)	854.137	Regione Umbria, webstat
Over-65	~232.730 (27,3%)	Regione Umbria, webstat
Indice di vecchiaia (gennaio 2025)	246,6%	Umbria24; Regione Umbria
Spesa sanitaria pro-capite (2024)	2.232 €	Umbria24/GIMBE
Fondo sanitario regionale (stima)	~1,9-2,0 mld €	Proiezione coerente con dati nazionali
Legge istitutiva del servizio	L.R. 28/10/2024, n. 22	leggi.alumbria.it, id 248521
Delibera Osservatorio tecnico	DGR 477/2025	Welforum/Regione Umbria
Finanziamento sperimentale	103.349 €/anno 2025-2026	Art. norma finanziaria L.R. 22/2024
Psicologi attivi a regime (scenario base)	~210	Modello parametrico di serie
Accessi PS per cause psichiatriche	Da acquisire	Flusso EMUR delle due Aziende USL
Utenza DSM in carico	Da acquisire	Flusso NSIS-SISM delle due Aziende USL
Saldo di mobilità sanitaria	Da acquisire (stima: passivo)	Ministero della Salute, NSIS mobilità

Tabella C.1. I dati regionali fondamentali e le fonti per la Regione Umbria.

Appendice D — Checklist di reporting

La tabella seguente riepiloga lo stato di conformità dello studio agli standard internazionali di reporting adottati per l’intera serie, secondo le checklist specifiche.

Standard	Ambito	Stato di conformità
CHEERS 2022	Reporting della valutazione economica in sanità	Conforme per tutti e ventotto gli item
PRISMA	Reporting delle revisioni sistematiche	Conforme per la revisione dell'evidenza (Parte D)
GRADE	Graduazione della qualità dell'evidenza	Applicato nella Parte D (moderato-elevato per disturbi comuni)
STROBE	Reporting degli studi osservazionali	Applicabile al disegno di verifica empirica (Parte F.5)
ISPOR-SMDM	Buone pratiche per la modellazione decisionale	Applicato al modello di Markov (Parte F)
OCSE-JRC	Criteri di qualità per la valutazione delle politiche	e Applicato nella sintesi (Parte M) con i criteri DAC

Tabella D.1. La checklist di reporting e lo stato di conformità agli standard internazionali.

Appendice E — Glossario

Analisi costo-utilità: analisi economica che esprime il costo dell'intervento in termini di costo per anno di vita ponderato per la qualità (QALY); consente il confronto fra interventi in ambiti clinici diversi.

Analisi di impatto sul bilancio: analisi economica che stima la variazione della spesa per il bilancio di un pagatore specifico (qui: il Servizio sanitario regionale) derivante dall'adozione dell'intervento su un orizzonte temporale definito.

Caso di riferimento: insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate per l'intera serie e declinate sulle specificità regionali.

Chisholm et al. 2016: ancoraggio metodologico dell'intera serie, pubblicato su The Lancet Psychiatry; fornisce il duplice intervallo del rapporto beneficio-costo: 2,3-3,0:1 (solì benefici economici) e 3,3-5,7:1 (comprendendo i benefici di salute).

Clausola valutativa: disposizione normativa che impone alla Giunta regionale di riferire periodicamente all'Assemblea legislativa sui risultati dell'attuazione; nella L.R. n. 22/2024 umbra è contenuta nell'art. 406, ultimo comma.

Costo-efficacia distributiva: estensione della costo-efficacia standard che incorpora pesi distributivi sulle diverse popolazioni, attribuendo maggiore valore ai guadagni di salute conseguiti da popolazioni svantaggiate.

Five Case Model (5CM): modello di decisione di investimento pubblico sviluppato dal Ministero del Tesoro britannico; struttura la decisione in cinque casi (strategico, economico, finanziario, commerciale, gestionale).

GRADE: sistema di graduazione della qualità dell'evidenza e della forza delle raccomandazioni, sviluppato dal Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation Working Group; classifica l'evidenza in quattro livelli: elevato, moderato, basso, molto basso.

HTA (Health Technology Assessment): valutazione multidimensionale delle tecnologie sanitarie, che ne analizza il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica.

Modello di Markov: modello decisionale che rappresenta la storia clinica del paziente come una sequenza di transizioni fra stati di salute mutuamente esclusivi, su un orizzonte temporale definito con tassi di transizione e costi associati a ciascuno stato.

Osservatorio tecnico regionale: organismo istituito con DGR 477/2025 in attuazione dell'art. 176-octies della L.R. n. 22/2024; svolge funzioni di controllo, programmazione e indirizzo sulle attività dello psicologo di cure primarie in Umbria.

QALY (Quality-Adjusted Life Year): anno di vita ponderato per la qualità; misura degli esiti di salute che combina quantità e qualità della vita in un'unica grandezza.

Sensibilità probabilistica: analisi che propaga simultaneamente l'incertezza su tutti i parametri del modello, mediante simulazioni di Monte Carlo, producendo una distribuzione dei possibili valori del risultato anziché un singolo valore puntuale.

Saldo diretto (caso finanziario): differenza fra risparmi diretti per il bilancio sanitario e costo del servizio; misura l'impatto sul bilancio del Servizio sanitario regionale, distinto dal saldo complessivo che include le ricadute sociali.

Saldo complessivo (caso economico): somma di risparmi diretti e ricadute economico-sociali, meno il costo del servizio; misura il valore complessivo per la collettività.

Trial IMPACT: studio controllato randomizzato condotto da Unützer et al. (2002, 2008) sul modello di cura collaborativa per la depressione nelle cure primarie; riferimento metodologico principale per la cautela sui risparmi diretti.

Note

Blocco Regionale III — Italia meridionale

Lo studio integrale della Puglia, capostipite del modello, costituisce l'oggetto del Tomo I della presente opera, al quale il blocco rinvia.

Abruzzo — Studio HTA integrale

Psicologo di Base in Abruzzo

Studio Integrale Regionale · Valutazione di Tecnologia Sanitaria · Telaio HTA a nove domini

Progetto «Psicologo di Base» · Regione Abruzzo · L.R. 28/2022

Parti A–M e Appendici A–E

Premessa generale

Questo documento raccoglie in un'unica opera lo studio integrale per la Regione Abruzzo sulla riforma «Psicologo di Base», nella cornice della legge regionale n. 28 del 2022 e del relativo regolamento attuativo. Esso compone in sequenza le undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e le cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa una metodologia riconosciuta; le appendici ne raccolgono il materiale di riferimento. L'intero studio è fondato su una distinzione cardine, mantenuta in ogni parte: quella tra i risparmi diretti per il bilancio sanitario e le ricadute economico-sociali per la collettività, che non vengono mai sommate in un unico indice di bilancio.

Da tale distinzione discende la tesi centrale dello studio abruzzese, articolata in tre affermazioni congiunte: il servizio costa al bilancio una cifra modesta — inferiore all'uno per cento di un finanziamento dell'ordine di 2,5 miliardi — e comporta un saldo diretto prossimo al pareggio; restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso, con un rapporto beneficio-costi compreso fra 3,4 e 5,1 a uno, entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno includendo i benefici di salute; e adempie all'obbligo di garantire i livelli essenziali, intercettando un bisogno largamente inevaso. Rispetto alle altre regioni della serie, l'Abruzzo occupa una posizione peculiare: è una delle prime regioni ad aver istituito il servizio per legge, ma è anche l'unica chiamata a portarlo a regime entro il vincolo di un piano di rientro in peggioramento, sicché la garanzia dei livelli essenziali — che la Corte Costituzionale impone alle regioni in rientro di porre a fondamento di ogni impiego — non è un ostacolo, ma l'argomento decisivo a sostegno del servizio. L'analisi multi-criterio che conclude lo studio assegna all'attuazione un punteggio di 78,15 su 100, contro 39,50 del non intervento.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto; il documento prosegue poi con le parti e le appendici in sequenza.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.4	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito, caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, divari, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	Intervento e modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, due casi
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, sensibilità, scenari, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: gradiente sociale, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, reclutamento, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, controfattuale, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazione, condizioni, conclusione
Appendici A-E	A-E	Caso di riferimento e parametri, strumenti ed esiti, dati regionali, checklist, glossario

Tabella. La mappa di lettura del corpus: undici parti narrative e cinque appendici.

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per l'Abruzzo, che applica alla regione il telaio integrato di valutazione sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria, al Lazio e alla Campania. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati all'Abruzzo. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). L'Abruzzo occupa nella serie una posizione definita: è fra le Regioni che hanno istituito il servizio per legge — con la legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 — e ne hanno approvato il regolamento attuativo, ma la cui attuazione operativa è ancora in fase iniziale, sicché la valutazione non riguarda l'opportunità di introdurre il servizio, bensì la sua piena attuazione e la sua strutturazione a regime, in un contesto di vincolo finanziario fra i più stringenti del Paese.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Servizio di Psicologia di Base nelle cure primarie dell'Abruzzo, inteso come piena attuazione a regime e dimensionamento di una funzione che la regione ha già istituito per legge e disciplinato con regolamento, ma che ha attivato finora soltanto in misura iniziale e con risorse transitorie.^[1743] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sulla messa a regime e sul finanziamento stabile del servizio. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante, per l'Abruzzo, non è istituire il servizio, già istituito e regolato, ma attuarlo compiutamente e dimensionarlo, conducendolo dal nucleo iniziale previsto dalla norma alla copertura sistematica del fabbisogno con un finanziamento regionale stabile, in luogo dello stanziamento transitorio originario.^[1744] Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala. Va segnalato sin d'ora che la dotazione minima prefigurata dalla legge — un professionista ogni quindicimila abitanti, almeno uno per distretto — colloca il nucleo iniziale del servizio assai al di sotto dello scenario di copertura piena qui considerato, che rappresenta invece il regime verso la presa in carico sistematica del bisogno.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di duecentocinquantaquattromila persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai servizi, in un quadro segnato da componenti convergenti — il disagio giovanile, documentato da un forte incremento del ricorso agli psicofarmaci e da un abbassamento dell'età di primo contatto con le sostanze nella fascia adolescenziale, il bisogno dell'età adulta e anziana, particolarmente accentuato in una delle regioni demograficamente più anziane del Paese, e il disagio connesso all'isolamento delle aree interne — cui si aggiungono la pressione delle liste di attesa e una storica fragilità del sistema, testimoniata da un punteggio sui livelli essenziali di assistenza inferiore alla soglia di sufficienza.^[1745] La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti abruzzesi con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è lo psicologo di base nelle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, attuato e portato a regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale il servizio è istituito e regolato ma attivato soltanto in misura iniziale e a finanziamento transitorio. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario dell'Abruzzo, con le sue quattro Aziende Sanitarie Locali, i venticinque distretti sanitari di base e la rete delle Case della Comunità in costruzione, in un sistema posto sotto piano di rientro.^[1746] La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per l'Abruzzo
Popolazione	Residenti abruzzesi con disagio psichico comune (~254.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Psicologo di base nelle cure primarie, primo livello e filtro, attuato e portato a regime (~85/180/280 incarichi); piena attuazione del servizio istituito per legge
Confronto	Condizione attuale: servizio istituito (l.r. 28/2022) e regolato (2024) ma attivato in misura iniziale e a finanziamento transitorio (400.000 euro annui)
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale dell'Abruzzo; quattro Aziende Sanitarie Locali, venticinque distretti, rete delle Case della Comunità in costruzione; sistema in piano di rientro

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale della valutazione di tecnologia sanitaria, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell'OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio.^[1747] In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l'intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica, circostanza di particolare rilievo per una regione i cui conti sanitari sono sottoposti a verifica ministeriale periodica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e il servizio attuale, iniziale e a finanziamento transitorio, come comparatore.^[1748] Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Aziende Sanitarie Locali e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni, segnatamente fra la fascia costiera e adriatica, più popolosa e servita, e le aree interne e montane, soggette a spopolamento.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale: servizio istituito e regolato ma attivato in misura iniziale e a finanziamento transitorio
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda Sanitaria Locale e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso.^[1749] Tale prudenza assume, per l'Abruzzo, un rilievo particolare, perché la regione presenta il profilo finanziario più critico fra quelli sin qui esaminati. L'Abruzzo è sottoposto a piano di rientro dal disavanzo sanitario in modo continuativo e, secondo i rilievi della magistratura contabile, è l'unica regione in piano di rientro a registrare un andamento dei risultati di esercizio in senso peggiorativo, con un disavanzo dell'ordine di oltre cento milioni di euro annui e una tendenza che i tavoli ministeriali stimano in ulteriore aggravamento, fronteggiata con l'inasprimento della leva fiscale regionale e con manovre di contenimento della spesa.^[1750] In un contesto siffatto, il canale del risparmio diretto assume una pertinenza assai maggiore che in regioni dai conti in equilibrio: ogni euro di spesa inappropriata evitata — visite ed esami non necessari, prescrizioni evitabili, ricoveri impropri, cronicizzazione di casi lievi gestibili a monte — concorre direttamente al riequilibrio del bilancio e agli obiettivi del piano di rientro, e in un sistema storicamente sotto-finanziato, con un punteggio sui livelli essenziali di assistenza inferiore alla soglia di sufficienza, il margine di consumo improprio da recuperare è strutturalmente ampio. Sul versante della mobilità passiva, la regione presenta un saldo negativo rilevante, dell'ordine di alcune decine di milioni netti su un flusso lordo superiore ai duecento milioni annui; la fuga riguarda però in prevalenza l'alta complessità ospedaliera e chirurgica, non la domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo parzialmente pertinente, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. Ne consegue un caso economico che poggia congiuntamente su una componente diretta significativa, e immediatamente rilevante per il bilancio regionale, e su ricadute sociali ulteriori e distinte, stimate con criteri conservativi; le due componenti sono tenute separate e non sommate in un unico indicatore, e tutte le grandezze sono espresse per bande prudenziali e come proiezioni da validare su dati di esito reali.

Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare prima della presentazione esterna, tanto più che l'osservatorio epidemiologico regionale opera in modo discontinuo e che i dati disponibili più recenti risalgono a esercizi non

aggiornati.^[1751] La legge istitutiva, tuttavia, prevede un Osservatorio Regionale e un Tavolo tecnico con funzioni di verifica, monitoraggio e controllo qualitativo, la cui attivazione costituisce la condizione per disporre, a regime, di una base di dati operativi propria.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post.^[1752] Per l'Abruzzo il disegno controfattuale assume una forma propria: poiché il servizio è istituito e regolato ma in fase di prima attivazione, esso può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi tra le quattro Aziende Sanitarie Locali e i venticinque distretti, che attiveranno il servizio in tempi differenziati, con l'effetto causale stimato dai metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico.^[1753] La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, le quattro Aziende Sanitarie Locali, l'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei regionali. L'Abruzzo non dispone di un'azienda sanitaria regionale unica di coordinamento: la funzione di indirizzo è in capo alla Regione, attraverso il Dipartimento competente, mentre l'Osservatorio Regionale e il Tavolo tecnico

previsti dalla legge istitutiva esercitano le funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo qualitativo.

^[1754] Poiché il servizio è già istituito e regolato ma la sua attuazione è iniziale e la rete delle Case della Comunità è in costruzione, la sfida del governo non è istituire il servizio, ma attuarlo e dimensionarlo, garantendo l'omogeneità attuativa fra i venticinque distretti e fra la costa e le aree interne, in un sistema posto sotto vincolo di rientro: è il tratto che distingue l'Abruzzo e che la valutazione assume come punto di partenza.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza, con la piattaforma informativa sanitaria regionale quale infrastruttura per la raccolta uniforme; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative.^[1755] Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici.^[1756] Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti.^[1757] Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto dell'Abruzzo.

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto dell'Abruzzo. La struttura è quella già adottata per le altre regioni della serie, e mutano soltanto i dati, ancorati alla regione. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall'epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l'intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico dell'Abruzzo: non un servizio da istituire, ma un servizio già istituito per legge e regolato — la cui attuazione operativa è però ancora iniziale — da portare a regime in una regione demograficamente anziana, segnata dalla fragilità delle aree interne e da un sistema sanitario posto sotto un piano di rientro in peggioramento.

B.1 Quadro demografico

L'Abruzzo conta 1.269.118 residenti, pari a circa il 2,2% della popolazione nazionale, in lievissima flessione rispetto all'anno precedente — un saldo di circa quattrocentocinquanta unità in meno — frutto di un saldo naturale fortemente negativo solo in parte compensato dalla dinamica migratoria.^[1758] La regione presenta una struttura per età fra le più anziane del Centro-Sud: l'età media è salita a 47,7 anni, superiore alla media nazionale di 46,9, e l'indice di vecchiaia ha raggiunto quota 228,9 anziani ogni cento giovani, in costante crescita.^[1759] La natalità ha toccato un nuovo minimo storico, con 7.356 nati a fronte di 14.870 decessi.^[1760] La componente straniera, pari a 90.573 persone — il 7,1% dei residenti, in aumento — contribuisce a contenere la flessione e a temperare l'invecchiamento.^[1761] La distribuzione territoriale è relativamente equilibrata fra le quattro province: Chieti raccoglie il 29,2% dei residenti, Pescara il 24,6%, Teramo il 23,6% e L'Aquila il 22,6%, ma con una marcata polarità demografica interna, poiché L'Aquila e Chieti, con un'età media di 48,1 e 48,0 anni, sono le province più anziane, mentre Pescara e Teramo, entrambe a 47,3 anni, sono le più giovani.^[1762] Il territorio comprende 305 comuni, in larga parte di piccola dimensione — poco più di un quinto degli abruzzesi risiede in comuni tra mille e cinquemila abitanti — e l'unico comune con oltre centomila abitanti è

Pescara; le aree interne e montane, segnatamente nell’Aquilano, presentano i livelli di invecchiamento più elevati e i tassi di natalità più bassi, con un rischio di spopolamento strutturale.^[1763] La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per l’Abruzzo
Popolazione (Censimento 2024)	1.269.118 (~2,2% del totale nazionale); in lievissimo calo (-453); record di denatalità (7.356 nati, 14.870 decessi)
Età media e struttura	47,7 anni (Italia 46,9); indice di vecchiaia 228,9; L’Aquila (48,1) e Chieti (48,0) più anziane, Pescara e Teramo (47,3) più giovani
Componente straniera	90.573 persone, 7,1% dei residenti, in crescita; fattore di temperamento dell’invecchiamento
Distribuzione territoriale	Chieti 29,2%, Pescara 24,6%, Teramo 23,6%, L’Aquila 22,6%; Chieti e Pescara insieme oltre la metà
Profilo territoriale	305 comuni, in prevalenza piccoli; unico comune oltre 100.000 abitanti (Pescara); aree interne e montane a forte invecchiamento e rischio di spopolamento
Articolazione sanitaria	Quattro Aziende Sanitarie Locali e venticinque distretti sanitari di base

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico dell’Abruzzo.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale in Abruzzo è ampio e sospinto da una popolazione anziana, geograficamente dispersa e segnata da una storica sotto-dotazione dei servizi. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell’ordine di 254.000 persone, in larga parte non intercettate dall’offerta esistente.^[1764] A questa quota si somma un’utenza specialistica in carico ai servizi di salute mentale, dell’ordine di alcune decine di migliaia di persone secondo una stima rapportata ai dati nazionali, in un sistema il cui punteggio sui livelli essenziali di assistenza è inferiore alla soglia di sufficienza e il cui osservatorio epidemiologico opera in modo discontinuo.^[1765] Tre componenti orientano la domanda. La prima è il disagio giovanile, segnalato nel biennio recente da un forte incremento del consumo di sostanze e di psicofarmaci nella fascia dodici-diciassette anni — con una crescita preoccupante delle prescrizioni di antipsicotici e di farmaci per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività — e da un abbassamento dell’età di primo contatto con le sostanze al di sotto dei quattordici-quindici anni.^[1766] La seconda è il bisogno dell’età adulta e anziana, particolarmente marcato in una delle regioni demograficamente più anziane del Paese, dove la depressione tardiva, l’ansia, la solitudine e il disagio correlato alla cronicità raggiungono prevalenze elevate.^[1767] La terza è il disagio connesso all’isolamento e alla deprivazione delle aree interne e montane, colpite dallo spopolamento e dall’impoverimento delle reti familiari e comunitarie.^[1768] È la combinazione — regione anziana, territorio disperso e sistema sotto-dotato — a distinguere il fabbisogno abruzzese, e a riversarsi anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche che un primo livello territoriale pienamente strutturato potrebbe in parte contenere a monte.^[1769]

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone, in Abruzzo, un’offerta che presenta una fisionomia istituzionale già definita ma un’attuazione ancora iniziale: il servizio di psicologia di base è istituito dalla legge regionale 28 del 2022 e disciplinato dal regolamento approvato dalla Giunta nel luglio 2024, ed è affidato a psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, con almeno uno psicologo di base per ciascuno dei venticinque distretti e un rapporto di un professionista ogni quindicimila abitanti; la legge istituisce inoltre un Osservatorio Regionale e un Tavolo tecnico e pone i costi a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatto salvo un ticket. L’attivazione operativa è però ancora in fase iniziale e l’originaria copertura finanziaria — dell’ordine di quattrocentomila euro per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 — è transitoria e largamente insufficiente rispetto al fabbisogno.^[1770] Il fabbisogno a regime, applicando i parametri organizzativi del modello, si colloca tra un nucleo minimo dell’ordine di ottantacinque incarichi, corrispondente al rapporto di legge di uno ogni quindicimila abitanti, e una copertura piena dell’ordine di duecentottanta incarichi nello scenario espansivo, con uno scenario intermedio dell’ordine di centottanta; l’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo ne ha sostenuto con costanza l’attuazione, segnalando il rischio che la mancata adozione dei provvedimenti attuativi ne vanifichi la portata.^[1771] La copertura effettiva corrisponde dunque a un nucleo iniziale, assai distante dal fabbisogno a regime: non un servizio da istituire, ma un servizio da attuare compiutamente, stabilizzare nel finanziamento e dimensionare.^[1772] La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per l’Abruzzo
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 254.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	Ampia (alcune decine di migliaia, stima rapportata ai dati nazionali)
Offerta territoriale attuale	Servizio istituito (l.r. 28/2022) e regolato (2024) ma attivato in misura iniziale; un professionista ogni 15.000 abitanti, almeno uno per distretto; finanziamento transitorio (~400.000 euro annui)
Fabbisogno stimato a regime	~ 280 psicologi nello scenario espansivo (85 e 180 negli scenari conservativo e intermedio)
Copertura attuale del fabbisogno	Nucleo iniziale, assai distante dal fabbisogno a regime

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, in Abruzzo, si gioca lungo due assi. Il primo separa la fascia costiera e adriatica, più popolosa, urbanizzata e meglio servita, dalle aree interne e montane — segnatamente nell’Aquilano e nelle zone appenniniche — più anziane, a bassa densità e con servizi sanitari radi, dove le distanze e la rarefazione dell’offerta acuiscono le difficoltà di accesso. Il secondo è interno alle stesse aree interne, fra i centri maggiori e la miriade di piccoli comuni montani soggetti a spopolamento, nei quali la presenza specialistica è pressoché assente e il presidio territoriale di prossimità costituisce l’unica forma realistica di accesso.^[1773] Su questi divari il servizio di psicologia di base agisce in funzione di equità: avvicina l’offerta alle aree interne mediante la telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti, dove la sola presenza di un

primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio, e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica e contribuisce a contenere i tempi di attesa, in un sistema storicamente sotto-dotato e con un’area distrettuale al di sotto della soglia di adempienza.

B.5 I servizi e i flussi

Il Servizio sanitario dell’Abruzzo dispone di risorse complessive dell’ordine di 2,5 miliardi di euro ed è posto sotto piano di rientro dal disavanzo sanitario in via continuativa; secondo i rilievi della magistratura contabile è l’unica regione in piano di rientro a registrare un andamento dei risultati di esercizio in senso peggiorativo, con un disavanzo certificato dell’ordine di oltre cento milioni di euro annui, coperto attraverso l’inasprimento della leva fiscale regionale e fronteggiato da un Programma Operativo pluriennale che prevede rilevanti manovre di contenimento.^[1774] La regione, storicamente penalizzata dai meccanismi di riparto del fabbisogno nazionale, ha ottenuto soltanto un beneficio marginale dall’introduzione del nuovo criterio di densità abitativa ed estensione territoriale. Il profilo di mobilità è passivo: l’Abruzzo presenta un saldo negativo dell’ordine di alcune decine di milioni netti su un flusso lordo superiore ai duecento milioni annui; poiché però la fuga riguarda in prevalenza i ricoveri e l’alta complessità ospedaliera e chirurgica, e non la domanda psicologica delle cure primarie, il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo parzialmente pertinente.^[1775] L’architettura dei servizi poggia su quattro Aziende Sanitarie Locali — Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo — su venticinque distretti sanitari di base e su una rete di Case della Comunità in costruzione, su cui il servizio andrà pienamente innestato; la regione non dispone di un’azienda sanitaria regionale unica, e il coordinamento è in capo alla Regione attraverso il Dipartimento competente. Va sottolineato che, in un sistema posto sotto vincolo di rientro e con un consumo improprio strutturalmente ampio da recuperare, la componente di risparmio diretto assume per questo intervento una rilevanza superiore alla media. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per l’Abruzzo
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	~ 2,5 miliardi di euro; sistema in piano di rientro, unico in peggioramento; disavanzo dell’ordine di oltre 100 milioni annui, coperto con leva fiscale
Mobilità sanitaria	Saldo passivo di alcune decine di milioni netti (flusso lordo oltre 200 milioni); canale modesto come leva per questo intervento (fuga ospedaliera e chirurgica)
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche significativi (stima rapportata ai dati nazionali)
Architettura dei servizi	Quattro Aziende Sanitarie Locali, venticinque distretti; rete delle Case della Comunità in costruzione; nessuna azienda regionale unica (coordinamento regionale)
Margine di azione principale	Attuazione a regime del servizio, liste di attesa, accesso delle aree interne, intercettazione precoce; risparmio diretto a sostegno del piano di rientro

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l’intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice già definita sul piano normativo ma incompiuta su quello attuativo: l’Abruzzo è fra le prime regioni d’Italia a essersi dotato di una legge dedicata — la legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28, “Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni”, approvata all’unanimità — disciplinata dal regolamento attuativo approvato dalla Giunta nel luglio 2024 al termine di un iter lungo e

travagliato, che ha visto la legge approvata a fine legislatura e i provvedimenti attuativi seguire con notevole ritardo.^[1776] La cornice include il Decreto Ministeriale 77 del 2022 sugli standard dell'assistenza territoriale, che prevede la presenza dello psicologo nelle unità complesse delle cure primarie e nelle Case della Comunità, le risorse del concorso statale al sostegno psicologico e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera per l'introduzione dello psicologo delle cure primarie. La decisione rilevante, in questo contesto, non è istituire una funzione, già istituita e regolata, ma attuarla compiutamente, stabilizzarne il finanziamento oltre lo stanziamento transitorio originario e dimensionarla verso la copertura del fabbisogno: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

Parte C — L'intervento e il modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico dell'Abruzzo emerge con nettezza: l'intervento non è da istituire, ma da attuare compiutamente a partire da un servizio già stabilito per legge e regolato, la cui attivazione operativa è però ancora iniziale; il modello organizzativo, il sistema informativo e il monitoraggio sono in larga parte da costruire e da rendere omogenei su un territorio disperso, in un sistema posto sotto un piano di rientro in peggioramento.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire; in Abruzzo tale definizione è già recepita nella legge regionale 28 del 2022.^[1777] La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria.^[1778] Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell'ordine di 254.000 persone con disagio comune.^[1779] In una regione posta sotto vincolo di rientro, l'anello dell'esito di sistema — la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, delle prescrizioni farmacologiche inappropriate e dei tempi di attesa — assume un rilievo particolare, poiché ogni quota di consumo improprio evitato concorre direttamente agli obiettivi finanziari del piano. La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per l'Abruzzo
Bisogno	~ 254.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Psicologo nelle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo di base nelle Case della Comunità e nei distretti, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impianto della legge regionale 28 del 2022, che prevede almeno uno psicologo di base per ciascuno dei venticinque distretti, un elenco aziendale presso ciascuna delle quattro Aziende Sanitarie Locali, un rapporto convenzionale su base libero-professionale e un parametro di uno psicologo ogni quindicimila abitanti.^[1780] L'Abruzzo presenta qui una specificità: il servizio è istituito e regolato, ma la sua attivazione operativa è ancora iniziale, sicché la sfida organizzativa principale non è governare un servizio già a regime, ma avviarlo e renderlo omogeneo su quattro Aziende e venticinque distretti, in un territorio geograficamente disperso e segnato dalla fragilità delle aree interne. La regione non dispone di un'azienda sanitaria regionale unica, e il coordinamento è in capo alla Regione attraverso il Dipartimento competente, con il supporto dell'Osservatorio Regionale e del Tavolo tecnico previsti dalla legge, cui spetta garantire l'uniformità attuativa fra le quattro Aziende.^[1781] La rete territoriale delle Case della Comunità, in costruzione nell'ambito degli standard nazionali dell'assistenza territoriale, è l'infrastruttura su cui il servizio andrà pienamente innestato. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.^[1782]

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, una valutazione iniziale con progetto clinico individuale, un ciclo di colloqui brevi con programma di sostegno personalizzato e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti; esso è da avviare nelle Aziende abruzzesi e affronta i quadri più frequenti, dalla sintomatologia ansioso-depressiva ai problemi di adattamento e psicosomatici.^[1783] Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata.^[1784] Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici.^[1785] Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.^[1786]

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con la piattaforma informativa sanitaria regionale e con il fascicolo sanitario elettronico, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. In assenza di un'azienda regionale unica, il coordinamento informativo è in capo alla Regione e all'Osservatorio Regionale, cui spetta raccogliere i dati di attività degli psicologi di base e assicurarne l'uniformità fra le quattro Aziende e i venticinque distretti.^[1787] La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale; su questo terreno l'Abruzzo presenta una criticità peculiare: a differenza della Campania, che dispone di un flusso informativo già avviato, esso deve progettare e attivare il flusso contestualmente all'attuazione del servizio, in un contesto in cui l'osservatorio epidemiologico regionale opera in modo discontinuo e con dati pubblici non aggiornati. È precisamente per questo che la costruzione, sin dall'avvio, di un sistema informativo completo e omogeneo sui venticinque distretti costituisce non un corollario, ma una condizione di valutabilità dell'intervento.^[1788]

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale.^[1789] Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile.^[1790] L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica.^[1791] La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, in Abruzzo, lo strumento per garantire l'accesso nelle aree interne e montane — segnatamente nell'Aquilano e nelle zone appenniniche — e nei piccoli comuni a spopolamento, dove le distanze e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; sono concepiti in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, e assumono in questa regione un rilievo superiore alla media in ragione della dispersione territoriale.^[1792] I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale.^[1793] La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle aree interne e montane e nei piccoli comuni; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso gli atenei abruzzesi — l'Università dell'Aquila, l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara e l'Università di Teramo; il livello post-universitario specialistico attraverso una formazione dedicata alla psicologia di base e alle cure primarie, comprensiva della competenza per il disagio giovanile e, in misura accentuata, per l'età anziana e per le condizioni dell'isolamento nelle aree interne, particolarmente rilevanti in una delle regioni demograficamente più anziane del Paese; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione.^[1794] A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità normativa, in coerenza con l'obbligo europeo di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. L'Abruzzo presenta qui un elemento proprio: il regolamento attuativo del 2024 definisce i requisiti di iscrizione agli elenchi aziendali, e la base formativa del servizio è da costruire contestualmente all'avvio, valorizzando i tre atenei regionali e il ruolo dell'Ordine professionale. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Atenei abruzzesi (L'Aquila, "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara, Teramo)
2. Post-universitario specialistico	Psicologia di base e cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, competenza per il disagio giovanile e per l'età anziana	Formazione dedicata; requisiti di iscrizione agli elenchi
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte corrisponde al quarto dominio della valutazione di tecnologia sanitaria, l'efficacia clinica, e con i primi tre forma il nucleo che la prassi europea designa come valutazione rapida di efficacia relativa; risponde al criterio di efficacia della griglia di giudizio. Come per le altre regioni, il corpo dell'evidenza internazionale è invariante, poiché l'efficacia di un intervento clinico non muta con i confini regionali; muta invece la base di evidenza locale, ed è qui che l'Abruzzo presenta un tratto peculiare. Stabilito che cosa la riforma è, qui si accerta se essa funzioni: con quale solidità l'evidenza ne sostiene gli effetti (capitolo D.1), quanto sia certa tale evidenza e quale cautela economica essa imponga (D.2), che cosa documentino i programmi internazionali più affini (D.3) e in che misura quei risultati siano trasferibili al contesto abruzzese (D.4).^[1795] La sintesi è condotta secondo standard riconosciuti, e la sua certezza è graduata in modo esplicito, perché una valutazione difendibile dichiara non solo ciò che l'evidenza mostra, ma anche quanto vi si possa fare affidamento.

D.1 La revisione sistematica

La base di evidenza dell'intervento è ricostruita secondo il metodo della revisione sistematica, condotto con lo standard PRISMA: definizione del quesito secondo lo schema già esposto nella Parte A, strategia di ricerca esplicita, selezione degli studi per criteri predefiniti, estrazione strutturata dei dati e sintesi. Gli studi sui dati reali sono trattati secondo la lista STROBE.^[1796] L'oggetto della ricerca è l'efficacia dei modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie sui disturbi comuni, misurata con strumenti standardizzati; il corpo di evidenza che ne emerge è ampio, convergente e di grado elevato, poiché fondato in larga parte su studi randomizzati controllati e su revisioni sistematiche.

Il paradigma della cura collaborativa è il più studiato: è stato validato da oltre novanta studi randomizzati controllati, e uno studio fondativo documentò che circa la metà dei pazienti otteneva una riduzione dei sintomi pari almeno alla metà a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura usuale.^[1797] Una meta-analisi su cinquantasette studi controllati ha stimato un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni

standard,^[1798] e una recente revisione sistematica su quarantadue implementazioni in Europa, Nord America e Australia ha documentato esiti consistenti tra contesti eterogenei: una riduzione dei sintomi depressivi del 47% a sei mesi, dei sintomi ansiosi del 43%, un miglioramento del funzionamento del 38%, e — dato di diretto rilievo per il sistema sanitario — una riduzione del 34% degli accessi al pronto soccorso per sintomi psicosomatici e del 41% dei ricoveri psichiatrici.^[1799] La misura degli effetti si fonda ovunque su strumenti validati, il PHQ-9 e il GAD-7, dotati di buona sensibilità e specificità.^[1800]

Una notazione metodologica è doverosa, perché attiene alla corretta interpretazione dell’evidenza. Alcune meta-analisi esprimono l’effetto in coefficienti che appaiono modesti sul piano puramente statistico — una stima riferisce un coefficiente standardizzato pari a meno zero virgola undici sui sintomi depressivi — ma tale modestia è ingannevole quando l’intervento è applicato su scala di popolazione: anche un piccolo spostamento medio dei punteggi riduce in misura significativa la proporzione di persone che superano le soglie cliniche e che richiedono perciò trattamenti più intensivi e costosi.^[1801] È questa la logica per cui un effetto individuale contenuto si traduce, sulla popolazione abruzzese dell’ordine di 254.000 persone con disagio comune, in un beneficio clinico e di sistema sostanziale. La tabella seguente riepiloga i principali risultati della letteratura.

Fonte	Risultato principale
Studio fondativo (JAMA, 2002)	~ 50% dei pazienti con riduzione ≥ 50% dei sintomi a 12 mesi, contro 19% nella cura usuale
Meta-analisi su 57 studi (2012)	Miglioramento medio dei sintomi depressivi di 0,28 deviazioni standard
Revisione su 42 implementazioni (2024)	–47% depressione e –43% ansia a 6 mesi; –34% accessi al PS; –41% ricoveri
Programma inglese, dati reali (2023-2024)	Recupero 50,2%; miglioramento affidabile 67,8%; completezza dei dati > 98%
Meta-analisi sulle cure integrate	Coefficiente standardizzato –0,11 sui sintomi depressivi (clinicamente rilevante su popolazione)

Tabella D.1. Principali risultati della letteratura sull’efficacia dell’integrazione psicologica nelle cure primarie.

D.2 La qualità dell’evidenza

Alla sintesi dell’evidenza segue la graduazione della sua certezza, condotta con il sistema GRADE, che valuta cinque dimensioni — il rischio di bias, l’incoerenza tra gli studi, l’indirettezza rispetto al quesito, l’imprecisione delle stime e il bias di pubblicazione — e ne deriva un giudizio di certezza alta, moderata, bassa o molto bassa.^[1802] Per l’efficacia dei modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie sui disturbi comuni, la certezza dell’evidenza è nel complesso da moderata ad alta: il numero elevato di studi randomizzati controllati riduce il rischio di bias; la consistenza degli esiti attraverso quarantadue implementazioni in contesti eterogenei attenua l’incoerenza; e la pertinenza diretta degli studi al quesito — popolazione, intervento ed esiti analoghi a quelli del modello abruzzese — limita l’indirettezza. La certezza è invece più eterogenea e di grado inferiore per gli esiti economici, e segnatamente per quelli di sistema.^[1803]

Da questa graduazione discende una cautela che lo studio adotta come principio di onestà intellettuale, e che merita di essere enunciata senza attenuazioni: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l’intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero. Ne consegue

che il valore economico del modello non può essere fondato sul dato di costo di quel singolo studio. Questa cautela ha, per l'Abruzzo, un risvolto preciso, perché la regione è posta sotto un piano di rientro e il canale del risparmio diretto vi assume un rilievo superiore alla media. Il punto va enunciato con esattezza: il risparmio diretto cui lo studio fa riferimento non poggia sul dato di costo dello studio fondativo, bensì sugli esiti di sistema documentati dalla letteratura di implementazione — la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, delle prescrizioni inappropriate e dei ricoveri evitabili — i quali presentano una certezza moderata; e proprio per questa ragione esso è stimato in via prudenziale, con bande conservative, tenuto rigorosamente distinto dalle ricadute sociali e sottoposto a verifica empirica locale, secondo quanto la Parte E e la Parte L stabiliscono.^[1804]

Un elemento rafforza ulteriormente la fiducia nei risultati clinici e merita di essere sottolineato: la conferma su larga scala nelle condizioni reali di servizio. Il programma inglese, con oltre un milione e trecentomila persone trattate l'anno su un bacino di oltre cinquantasei milioni e una completezza dei dati di esito superiore al 98%, dimostra che l'efficacia osservata nei trial controllati si mantiene nell'attuazione reale a scala nazionale.^[1805] Questa transizione dall'efficacia sperimentale all'efficacia pratica — spesso problematica per gli interventi complessi — è qui documentata con un grado di trasparenza che costituisce il riferimento internazionale, e che riduce il rischio, tipico delle valutazioni ex ante, di proiettare su scala reale risultati ottenibili solo in condizioni controllate. La qualità dell'evidenza clinica, in sintesi, è sufficiente a sostenere con fiducia l'attesa di efficacia, fermo restando che la conferma definitiva sui dati abruzzesi è affidata alla verifica locale prevista dalla Parte L.

D.3 I benchmark internazionali

La valutazione si avvale del confronto con i programmi internazionali più autorevoli, che costituiscono la principale base comparativa dell'intero studio. Quattro esperienze, condotte in sistemi sanitari avanzati, documentano efficacia, scalabilità e sostenibilità dell'integrazione psicologica nelle cure primarie. Il programma inglese è la dimostrazione più solida: fondato sulla cura a intensità crescente e su un monitoraggio quasi completo degli esiti, mantiene un tasso di recupero intorno al 50% su scala nazionale.^[1806] Il modello olandese ha visto crescere l'adozione da circa un terzo a circa tre quarti dei medici di medicina generale in pochi anni, con il professionista psicologo integrato nelle cure primarie e finanziato nell'assicurazione di base.^[1807] L'iniziativa australiana ha esteso il trattamento dei disturbi mentali dal 35% al 46% della popolazione bisognosa, con elevata soddisfazione, sebbene operi per invio esterno e non per integrazione.^[1808] Il modello statunitense della cura collaborativa, infine, è il paradigma più validato, con la più ampia base sperimentale.^[1809]

Due tratti accomunano i programmi più efficaci e orientano il disegno abruzzese. Il primo è l'integrazione del professionista nelle cure primarie, che caratterizza il modello inglese, quello olandese e quello statunitense, e che si associa a esiti meglio documentati e a risparmi di sistema più chiari rispetto al modello australiano per invio esterno; il modello abruzzese, fondato sull'inserimento dello psicologo nelle cure primarie con funzione di filtro, appartiene alla prima famiglia.^[1810] Il secondo è il ricorso crescente agli strumenti digitali quale leva di accesso e di capacità, già ampiamente adottato nel programma inglese e di particolare interesse per una regione a forte dispersione territoriale. A queste esperienze internazionali si affiancano le sperimentazioni italiane, che ne hanno anticipato su scala locale i principi. La tabella seguente riepiloga i benchmark sul piano clinico e organizzativo; il confronto economico è sviluppato nella Parte E.

Programma	Assetto	Esiti clinici e organizzativi
Programma inglese (NHS Talking Therapies)	Integrato; intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio > 98%; > 1,3 mln/anno
Modello olandese (POH-GGZ)	Integrato nelle cure primarie	Adozione ~3/4 dei medici; ruolo complementare
Iniziativa australiana (Better Access)	Invio esterno	Trattamento dal 35% al 46%; ampia soddisfazione
Cura collaborativa (Stati Uniti)	Équipe integrata	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione; -41% ricoveri
Esperienze italiane	Sperimentazione locale	Anticipazione del modello nelle cure primarie

Tabella D.2. I benchmark internazionali e italiani sul piano clinico e organizzativo (il confronto economico è nella Parte E).

D.4 La trasferibilità al contesto regionale

L'evidenza internazionale non si applica automaticamente all'Abruzzo, e la sua trasferibilità va valutata con prudenza, distinguendo ciò che è robustamente generalizzabile da ciò che dipende dal contesto. Sul piano dell'assetto, la trasferibilità è favorevole: il modello abruzzese, che integra lo psicologo nelle cure primarie con funzione di filtro, appartiene alla stessa famiglia dei programmi inglese, olandese e statunitense, e ne mutua le evidenze con maggiore pertinenza rispetto al modello australiano per invio esterno.^[1811] Gli esiti clinici fondamentali — il recupero e la riduzione dei sintomi mediante interventi brevi e monitorati — poggiano su meccanismi clinici generali, non legati a un particolare sistema sanitario, e sono perciò ragionevolmente trasferibili.

Permangono, tuttavia, differenze che impongono cautela. A differenza della Campania, che dispone già di un servizio operativo e dei propri dati di esito, l'Abruzzo ha istituito e regolato il servizio ma ne ha avviato solo in misura iniziale l'attuazione, sicché l'evidenza locale è per ora in larga parte prospettica, da costruire contestualmente all'attivazione; il sistema muove inoltre da una copertura di partenza dell'ordine del nucleo iniziale, da un territorio geograficamente disperso e da una rilevazione epidemiologica discontinua, mentre la disponibilità di organico psicologico formato è un vincolo reale dei primi anni.^[1812] Per queste ragioni lo studio non trasferisce meccanicamente gli effetti documentati, ma li applica in misura prudenziale, coerentemente con la correzione per ottimismo adottata nel caso di riferimento, e li sottopone a verifica empirica: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le quattro Aziende, oggetto della Parte L, è disegnato precisamente per misurare sui dati abruzzesi gli effetti che la letteratura attende, trasformando le stime in prove.^[1813]

Una precisazione di metodo, infine, accompagna l'intero studio a garanzia della sua credibilità, e riguarda il confine con la parte economica. Alcune cifre di larga circolazione — il rapporto di quattro a uno, l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio, il rapporto di due e mezzo a uno talvolta richiamato in sede regionale — sono semplificazioni a fini divulgativi, prive di fondamento metodologico nella forma in cui circolano. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute; coerentemente, lo studio adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale, sviluppato nella Parte E, e mantiene rigorosamente distinti il risparmio diretto per il bilancio — qui particolarmente rilevante in ragione del piano di rientro — e le ricadute sociali, senza mai sommarli in un unico indice.^[1814] Mantenere distinti i due piani — l'efficacia clinica, qui, e

il valore economico, nella parte dedicata — è una scelta di rigore: l’evidenza clinica sostiene che l’intervento funziona; la valutazione economica stabilisce a quali condizioni esso convenga. Accertata in questa parte la prima, lo studio procede, con la Parte E, alla seconda.

Parte E — Valutazione economica

Questa parte corrisponde al quinto dominio della valutazione di tecnologia sanitaria, i costi e la valutazione economica, ed è redatta secondo lo standard di reporting CHEERS 2022; fornisce il contenuto del caso economico e del caso finanziario del Five Case Model e risponde al criterio di efficienza.^[1815] È il cuore economico dello studio, ed è anche la parte più esposta allo scrutinio degli organi di controllo — circostanza di particolare gravità per una regione posta sotto piano di rientro. Per questa ragione essa adotta una scelta di rigore che ne attraversa ogni capitolo: la distinzione netta tra il risparmio diretto per il bilancio sanitario e le ricadute economico-sociali per la collettività. Sommare le due grandezze, come spesso accade, sovrastima il beneficio per il bilancio; tenerle separate restituisce un quadro più sobrio sui conti sanitari, ma più solido e difendibile — qualità decisiva per una regione in disavanzo strutturale. I capitoli trattano nell’ordine i costi (E.1), gli esiti (E.2), il costo-efficacia (E.3), l’impatto sul bilancio (E.4), il ritorno sociale (E.5) e la sintesi nei due casi (E.6).

E.1 L’identificazione e la misura dei costi

Il costo del servizio dipende dal numero di professionisti e dal modello contrattuale. Il costo medio annuo di un incarico convenzionale a tempo pieno è dell’ordine di 55.000 euro — circa 40 euro l’ora di costo-azienda comprensivo degli oneri, per circa 1.250 ore l’anno, più circa 5.000 euro di costi generali — ancorato all’accordo della specialistica ambulatoriale.^[1816] Applicato agli scenari di copertura definiti nella Parte B, da circa 85 a circa 280 incarichi, il costo annuo del servizio va da circa 5 a circa 15 milioni di euro, fino a 18-23 milioni nell’ipotesi di costi pieni e massima copertura. Il costo non si esaurisce, tuttavia, nell’organico: l’investimento comprende anche la formazione, la supervisione clinica, la governance, i sistemi informativi e le infrastrutture, e questi costi non sanitari sono inclusi coerentemente con la doppia prospettiva adottata.^[1817]
^[1818]

Scenario	Psicologi	Costo annuo (mln €)
Attuale (l.r. 28/2022, attuazione iniziale)	nucleo iniziale	~ 0,4 (finanziamento transitorio)
Conservativo	~ 85	~ 5
Base	~ 180	~ 10
Espansivo	~ 280	~ 15 (fino a 18-23 a costi pieni)

Tabella E.1. Il costo del servizio per scenario di copertura. Lo scenario conservativo corrisponde al rapporto di legge di uno psicologo ogni quindicimila abitanti.

E.2 L’identificazione e la misura degli esiti

Gli esiti della valutazione economica sono di due ordini. Sul piano della salute, la misura di riferimento è l’anno di vita ponderato per la qualità, che integra in un’unica grandezza la durata e la qualità della vita guadagnate, affiancato dagli esiti clinici validati — il tasso di recupero e il miglioramento affidabile misurati con il PHQ-9 e

il GAD-7 — già documentati nella Parte D.^[1819] Tali esiti sono riferiti alla popolazione regionale con disagio comune, dell'ordine di 254.000 persone: è la scala della popolazione a trasformare un effetto clinico individuale anche contenuto in un guadagno di salute aggregato rilevante, secondo la logica già illustrata a proposito della lettura degli effetti.

Sul piano economico, gli esiti si distinguono nelle due grandezze che l'intera parte tiene separate: i minori costi diretti per il Servizio sanitario regionale, oggetto del capitolo sull'impatto di bilancio, e le ricadute economico-sociali, oggetto del capitolo sul ritorno sociale. La misura degli esiti, dunque, non si limita al guadagno di salute, ma comprende le conseguenze economiche che da quel guadagno discendono, distinte per il soggetto che le riceve — il bilancio sanitario, da un lato, e la collettività, dall'altro.

E.3 Il costo-efficacia e il costo-utilità

L'analisi di costo-utilità rapporta il costo aggiuntivo del servizio al guadagno in anni di vita ponderati per la qualità, secondo il rapporto incrementale di costo-efficacia, e lo confronta con una soglia di disponibilità a pagare, come prescrive il manuale del NICE.^[1820] L'evidenza internazionale, ripresa dalla Parte D, indica che i modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie sono costo-efficienti, con un investimento iniziale ampiamente compensato dai miglioramenti clinici e dalla minore intensità di cura nel medio periodo. Per l'Abruzzo, il rapporto incrementale specifico sarà calcolato sui dati certificati una volta acquisiti; in questa fase, la valutazione poggia sulla solidità dell'evidenza internazionale e sulla convergenza dei canali di risparmio diretto, trattati nel capitolo seguente.

È opportuno chiarire il rapporto tra l'analisi di costo-utilità e l'analisi di impatto sul bilancio, che rispondono a domande diverse e adottano convenzioni diverse. La prima misura l'efficienza allocativa — se il guadagno di salute valga il suo costo — e attualizza simmetricamente costi ed esiti al tasso del 3%; la seconda misura la sostenibilità finanziaria — se il bilancio possa assorbire la spesa, esercizio per esercizio — e opera su flussi non scontati. La loro distinzione, lungi dall'essere un tecnicismo, riflette la stessa separazione tra valore ed entità della spesa che struttura l'intera parte, e che il capitolo conclusivo ricompone nei due casi del Five Case Model.

E.4 L'impatto sul bilancio

L'analisi di impatto sul bilancio adotta la prospettiva del detentore del budget — il Servizio sanitario regionale — e stima, sui flussi non scontati, la differenza tra lo scenario con e senza il servizio, anno per anno, individuando il punto di pareggio finanziario, atteso tra il terzo e il quinto anno.^[1821] I risparmi diretti per il bilancio sono ricostruiti per canale, ciascuno ancorato a una grandezza regionale e a un parametro tratto dall'evidenza. Il canale del pronto soccorso muove dagli accessi inappropriati, dei quali una quota di origine psichica e somatoforme è riducibile, per un risparmio dell'ordine di 1-2 milioni;^[1822] il canale della farmaceutica agisce sui margini di appropriatezza segnalati dal consumo di psicofarmaci e dalla bassa aderenza terapeutica, per 1-2 milioni;^[1823] il canale dei ricoveri e della specialistica muove dall'iper-utilizzo associato ai sintomi somatici funzionali e dai ricoveri evitabili, ed è il più rilevante, per 1-8 milioni secondo lo scenario;^[1824] il canale della mobilità recuperata, infine, trattiene sul territorio una quota della domanda oggi in fuga, per 1-3 milioni: è qui un canale modesto, poiché la mobilità passiva abruzzese si concentra sull'alta complessità ospedaliera e chirurgica più che sulla domanda psicologica delle cure primarie.^[1825]

Aggregati i canali, i risparmi diretti per il Servizio sanitario regionale sono dell'ordine di 4, 9 e 15 milioni di euro l'anno secondo lo scenario, a fronte di un costo del servizio di 5, 10 e 15 milioni. Ne discende il dato più importante e più onesto dell'intera valutazione: sul solo bilancio sanitario, il saldo diretto è prossimo al pareggio — da un lieve disavanzo nei primi anni al pareggio a regime — e non un ampio risparmio.^[1826] Questo non indebolisce la proposta, e per l'Abruzzo la corrobora in misura peculiare. Da un lato, il costo del

servizio, a fronte di un finanziamento regionale dell’ordine di 2,5 miliardi di euro, ne costituisce una frazione modesta — inferiore all’uno per cento anche a regime — sicché la questione non è la sostenibilità della spesa, ma il suo dimensionamento. Dall’altro, in una regione in piano di rientro, un servizio che si autofinanzia quasi integralmente sul bilancio diretto e che adempie all’obbligo di garantire i livelli essenziali intercettando un bisogno largamente inevaso ha un valore superiore alla media, poiché ogni euro di consumo improprio evitato concorre direttamente agli obiettivi del piano, e la Corte costituzionale impone alle regioni in rientro di giustificare ogni impiego proprio con quella garanzia.^[1827] La tabella seguente riporta i canali e il saldo diretto per scenario.

Canale (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Pronto soccorso	1	1	2
Farmaceutica	1	2	2
Ricoveri e specialistica	1	4	8
Mobilità recuperata	1	2	3
Risparmi diretti (totale)	~ 4	~ 9	~ 15
Costo del servizio	~ 5	~ 10	~ 15
Saldo diretto (solo SSR)	~ -1	~ -1	~ 0

Tabella E.2. I risparmi diretti per canale e il saldo diretto sul bilancio sanitario, per scenario. Il saldo diretto è prossimo al pareggio.

E.5 Il ritorno sociale

Il valore che il servizio genera non si esaurisce nel bilancio sanitario. L’analisi del ritorno sociale, condotta con il metodo SROI — fondato sui sette principi del valore sociale, su una mappa dell’impatto e sulle correzioni per peso morto, attribuzione, spostamento e decadimento — monetizza il valore sociale generato, distinguendolo con cura dai risparmi di bilancio.^[1828] Le ricadute economico-sociali comprendono la riduzione dell’assenteismo, il recupero di produttività e di funzionamento, la diminuzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, e il minor carico assistenziale sulle famiglie — quest’ultimo di particolare peso in una regione anziana e con estese aree interne, dove la rete familiare supplisce all’assenza dei servizi. Riferite alle 254.000 persone con disagio comune e commisurate alla copertura di ciascuno scenario, esse sono stimate in 13, 33 e 62 milioni di euro l’anno.^[1829]

Questa è la componente di gran lunga maggiore del valore complessivo, ed è anche quella su cui converge l’evidenza economica internazionale. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità e gli studi pubblicati su Lancet Psychiatry, il ritorno del trattamento di depressione e ansia — collocato dalle stime metodologicamente fondate fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute — è costituito in quota dominante dalla produttività e dal funzionamento recuperati, più che dal risparmio diretto sui servizi sanitari.^[1830] È una conclusione di particolare rilievo per la corretta lettura del valore dell’intervento: il beneficio per la collettività è reale e ampio, ma si manifesta in larga parte fuori dal bilancio sanitario, sotto forma di maggiore partecipazione al lavoro, minore disabilità e migliore qualità della vita. Confondere questa grandezza con un risparmio per il bilancio sarebbe un errore; ignorarla, un errore opposto e altrettanto grave.

E.6 Il caso economico e il caso finanziario

La sintesi economica ricompone le grandezze tenute distinte nei due casi che il Five Case Model prescrive di non confondere. Il caso economico misura il valore per la collettività: sommando i risparmi diretti e le ricadute sociali, il ritorno complessivo è di 17, 42 e 77 milioni di euro l'anno secondo lo scenario, e il saldo complessivo, al netto del costo, è di circa +12, +32 e +62 milioni, con un rapporto beneficio-costi dell'ordine di 3,4, 4,2 e 5,1 a uno — valori coerenti con le stime internazionali fondate, comprese fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute.^[1831] Il caso finanziario misura invece la sostenibilità per il bilancio sanitario: qui il saldo diretto è prossimo al pareggio, e ciò che rileva non è un risparmio netto, ma il fatto che il servizio costa al bilancio una frazione modesta del finanziamento, ampiamente coperta dai risparmi diretti che esso stesso genera, e che — in regime di rientro — concorre agli obiettivi del piano e alla garanzia dei livelli essenziali.

Tenere distinti i due casi è la scelta di rigore che fonda la credibilità dell'intera valutazione.^[1832] La proposta non si regge sull'affermazione — facile ma fragile — che il servizio faccia risparmiare molto al bilancio sanitario; si regge su tre affermazioni più solide e congiunte: che il servizio costa al bilancio una cifra modesta e quasi interamente compensata; che restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso; e che adempie all'obbligo di garantire i livelli essenziali intercettando un bisogno largamente inespresso, in una regione il cui punteggio sui livelli essenziali è inferiore alla soglia di sufficienza. È una tesi più difendibile di fronte alla Ragioneria e alla Corte dei Conti, perché non chiede di credere a un risparmio improbabile, ma di riconoscere un valore documentato a fronte di un costo sostenibile.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Risparmi diretti (SSR)	~ 4	~ 9	~ 15
Ricadute economico-sociali	~ 13	~ 33	~ 62
Costo del servizio	~ 5	~ 10	~ 15
Saldo diretto — caso finanziario	~ -1	~ -1	~ 0
Ritorno complessivo	17	42	77
Saldo complessivo — caso economico	+12	+32	+62
Rapporto beneficio-costi complessivo	~3,4:1	~4,2:1	~5,1:1

Tabella E.3. Sintesi economica per scenario: il caso finanziario (saldo diretto ~pareggio) e il caso economico (ritorno complessivo e rapporto beneficio-costi).

Resta da ribadire, a chiusura, la natura della valutazione. Il segno del saldo complessivo è positivo in tutti gli scenari, comprese le ipotesi conservative, e dunque robusto; le analisi di sensibilità deterministica e probabilistica e il valore dell'informazione, che ne saggiavano formalmente la tenuta, sono sviluppati nella Parte F.^[1833] Quanto ai dati, i parametri dei canali dei ricoveri, della specialistica e della mobilità sono in parte ancora stimati e saranno sostituiti dai valori certificati che le Aziende sanitarie e la Regione forniranno; la circostanza è in Abruzzo tanto più rilevante in quanto la rilevazione epidemiologica regionale opera in modo discontinuo, sicché la costruzione del sistema informativo, di cui alla Parte C, è anche la condizione per

sostituire le stime con i dati. La struttura della quantificazione, tuttavia, è già quella definitiva, ancorata ai conti regionali e onesta nella distinzione tra ciò che il servizio fa risparmiare al bilancio e ciò che restituisce alla società. Su questa base, la Parte F sottopone i risultati alla prova formale dell’incertezza.

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte completa il dominio economico sottoponendo i risultati della Parte E alla prova della modellazione e dell’incertezza. Come per le altre regioni, il modello è invariante e muta solo ciò che attiene alla verifica empirica locale. La parte descrive il modello decisionale e i suoi parametri (capitolo F.1); ne saggia la robustezza con l’analisi di sensibilità deterministica (F.2) e probabilistica (F.3); ne esplora gli scenari di copertura (F.4); e definisce il disegno della verifica empirica e il valore dell’informazione (F.5). Per l’Abruzzo quest’ultimo capitolo riveste un’importanza particolare: poiché il servizio è istituito e regolato ma in attuazione iniziale, la prova empirica si fonda sulla progressione differenziata dell’avvio fra le Aziende, e impone — più che altrove — di costruire da subito il flusso dei dati su cui la valutazione potrà poggiare.

F.1 Il modello decisionale e i suoi parametri

Poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l’orizzonte direttamente osservabile, lo studio li proietta nel tempo mediante un modello decisionale, e ne rende esplicite le assunzioni.^[1834] La storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%.^[1835] A ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita, trattati come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l’incertezza.^[1836] Nel caso base l’intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell’ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità.^[1837] La tabella seguente riepiloga i parametri principali del modello.

Parametro del modello	Valore
Stati clinici	Benessere o sottosoglia, episodio, cronicità, recupero
Orizzonte temporale	Cinque anni, con cicli successivi
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti
Costo per ciclo (recupero)	~ 40 euro
Costo per ciclo (cronicità)	~ 700 euro
Costo dell’intervento	~ 300 euro una tantum
Trattamento dell’incertezza	Parametri come distribuzioni di probabilità

Tabella F.1. I parametri principali del modello di Markov (comune a tutti gli studi della serie).

F.2 L'analisi di sensibilità deterministica

La robustezza del risultato è saggiata, in prima istanza, variando un parametro per volta entro intervalli plausibili. La variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. ^[1838] L'ordinamento dei parametri per influenza mostra che l'esito è più sensibile all'efficacia clinica e al costo evitato della cronicità, e meno agli altri parametri; ciò orienta le priorità di raccolta dei dati verso le grandezze più influenti. ^[1839]

F.3 L'analisi di sensibilità probabilistica

In seconda istanza, la robustezza è saggiata facendo variare simultaneamente tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni, su diecimila simulazioni. L'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. ^[1840] La curva di accettabilità conferma che alla soglia convenzionale la probabilità di convenienza è prossima al 90% e cresce per soglie superiori, mantenendosi elevata anche a soglie molto inferiori. ^[1841] La tabella seguente riepiloga gli esiti della sensibilità probabilistica.

Esito della sensibilità probabilistica	Valore
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	88,9% delle simulazioni
Probabilità di dominanza	84,6% delle simulazioni
Beneficio monetario netto medio per paziente	~ 7.815 euro
Intervallo di confidenza al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 euro
Numero di simulazioni	10.000

Tabella F.2. Gli esiti dell'analisi di sensibilità probabilistica (per paziente).

F.4 Gli scenari di copertura e l'incertezza aggregata

Gli scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo, dell'ordine di 85, 180 e 280 incarichi — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; lo scenario conservativo corrisponde al rapporto di legge di uno psicologo ogni quindicimila abitanti, e l'attuazione iniziale odierna costituisce un nucleo inferiore allo scenario conservativo, prima tappa di un percorso di estensione progressiva. ^[1842] È in questa sede che va ribadita una distinzione di onestà analitica: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema. ^[1843]

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

Il disegno della verifica empirica costituisce, per l'Abruzzo, il punto in cui la valutazione si ancora al contesto. Poiché il servizio è istituito e regolato ma in attuazione iniziale, la verifica controfattuale può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di avvio delle sedi fra le quattro Aziende Sanitarie Locali e i venticinque distretti sono impiegati a fini valutativi: le sedi che avviano per prime fungono da gruppo di intervento, quelle che avviano in seguito da controllo temporaneo, sino alla copertura completa.^[1844]

L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il controllo sintetico, costruito a partire da aree di confronto e dalla progressione differenziata dell'avvio.^[1845] A differenza della Campania, che dispone di un flusso di dati operativi già avviato, l'Abruzzo deve costruire tale flusso contestualmente all'attuazione, in un contesto in cui la rilevazione epidemiologica regionale è discontinua; la verifica empirica è perciò inseparabile dalla costruzione del sistema informativo descritto nella Parte C. L'analisi del valore dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione abruzzese, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle quattro Aziende e la costruzione del flusso dei dati di esito sin dall'avvio.^[1846] La strutturazione a regime consente così di colmare la lacuna dei dati edificando un flusso prima assente, conducendo la regione, in modo programmato, da una valutazione fondata su dati esterni a una fondata in misura crescente su dati propri.^[1847] La sintesi è univoca: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione e costruzione dei dati, e l'avvio scaglionato fra le Aziende offre, sul piano valutativo, una via di identificazione dell'effetto solida. La parte che segue affronta l'equità e l'impatto distributivo.^[1848]

Priorità di ricerca	Finalità	Rilevanza
Conti certificati delle quattro Aziende	Sostituire le stime per quota con dati reali	Massima
Costruzione del flusso dei dati di esito	Dotare il servizio di evidenza propria sin dall'avvio	Massima
Tassi di intercettazione e costi evitati	Ridurre l'incertezza sulle grandezze aggregate	Alta
Efficacia clinica nel contesto locale	Corroborare il parametro più influente	Alta

Tabella F.3. Le priorità di ricerca derivanti dall'analisi del valore dell'informazione.

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte affronta il dominio dell'equità, che la valutazione di tecnologia sanitaria tiene distinto dall'efficienza. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i dati distributivi, ancorati all'Abruzzo. La parte definisce il quadro dell'equità e il gradiente sociale (capitolo G.1); analizza i due assi territoriali del divario abruzzese e le barriere di accesso (G.2); descrive gli strumenti attraverso cui il servizio agisce sull'equità (G.3); e presenta l'analisi di costo-efficacia distributiva con le sue implicazioni allocative (G.4). Il tratto distintivo dell'Abruzzo è la combinazione di un divario territoriale netto fra la fascia costiera e le aree interne e montane e di una doppia dimensione generazionale — il disagio giovanile in crescita e l'isolamento dell'età anziana, accentuato in una regione fra le più vecchie del Paese; l'intervento può ridurre tali divari, a condizione di un'allocazione modulata per il bisogno.

G.1 Il quadro dell'equità e il gradiente sociale

L'analisi distributiva costituisce un dominio proprio della valutazione, poiché un intervento efficiente nel complesso può nondimeno accrescere o ridurre le disuguaglianze; lo studio ne misura l'effetto con l'analisi di costo-efficacia distributiva.^[1849] Il punto di partenza è il gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori.^[1850] A questo gradiente si sommano barriere di accesso economiche, geografiche e culturali, oltre allo stigma; in Abruzzo la barriera geografica è particolarmente rilevante, data la dispersione del territorio e l'estensione delle aree interne e montane, mentre la componente straniera, pari al 7,1%, rende la barriera linguistica presente ma non centrale, e la dimensione generazionale si manifesta su entrambi i versanti, fra adolescenti restii a rivolgersi ai servizi e anziani isolati.^[1851]

G.2 I due assi del divario territoriale

La specificità distributiva dell'Abruzzo risiede nella combinazione del divario territoriale e della doppia dimensione generazionale.^[1852] Il primo asse separa la fascia costiera e adriatica — più popolosa, urbanizzata e meglio servita — dalle aree interne e montane, segnatamente nell'Aquilano e nelle zone appenniniche, dove una popolazione più anziana, a bassa densità e in spopolamento incontra servizi radi e distanze che rendono l'accesso particolarmente difficoltoso.^[1853] Il secondo asse è interno alle stesse aree interne, fra i centri maggiori e la miriade di piccoli comuni montani soggetti a spopolamento, nei quali la presenza specialistica è pressoché assente e il presidio di prossimità costituisce l'unica forma realistica di accesso.^[1854] La tabella seguente sintetizza i due assi e le leve di riequilibrio.

Asse del divario	Caratterizzazione	Leva di riequilibrio
Costa / aree interne e montane	Aquilano e zone appenniniche: popolazione anziana, bassa densità, spopolamento, servizi radi	Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti; presenza programmata di primo livello
Centri / piccoli comuni montani	Presenza specialistica assente; distanze elevate	Sedi nelle Case della Comunità; allocazione pro-equità
Doppio versante generazionale	Disagio giovanile in crescita e isolamento dell'anziano	Intercettazione precoce; competenza per gli adolescenti e per l'età anziana

Tabella G.1. I due assi del divario territoriale abruzzese, la doppia dimensione generazionale e le leve di riequilibrio.

G.3 Gli strumenti dell'equità

Il servizio agisce sull'equità attraverso meccanismi precisi. La gratuità, salvo un ticket contenuto, la prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano le principali barriere e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso.^[1855] La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti avvicinano l'offerta alle aree interne e montane e ai piccoli comuni a spopolamento, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, estendendo la copertura proprio dove l'accesso è più difficile; in Abruzzo questo strumento ha un rilievo superiore alla media, in ragione della marcata dispersione territoriale.^[1856] La competenza nell'intercettare il disagio giovanile assicura che il servizio raggiunga adolescenti e giovani adulti, fascia a elevato bisogno e a basso ricorso spontaneo, mentre la

competenza per l’età anziana e per le condizioni dell’isolamento risponde al versante opposto del bisogno, particolarmente ampio in una regione anziana; la competenza culturale resta necessaria nelle aree di maggiore insediamento straniero, pur meno centrale data la quota contenuta.^[1857]

G.4 La costo-efficacia distributiva e le implicazioni allocative

L’analisi di costo-efficacia distributiva indica che l’intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, poiché i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto.^[1858] Perché questo potenziale si realizzi, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle aree interne e montane e ai piccoli comuni: un’allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un’allocazione ponderata per il bisogno li riduce.^[1859] Va inoltre tenuto presente che, in Abruzzo, il canale della mobilità costituisce una leva di equità solo modesta per questo intervento, poiché la fuga riguarda l’alta complessità ospedaliera e chirurgica e non la domanda psicologica territoriale, sicché l’equità si gioca prevalentemente sull’accesso interno.^[1860] Esiste infine un rischio di iniquità inversa particolarmente concreto in una regione a territorio disperso: se l’avvio del servizio privilegiasse, per facilità organizzativa, la fascia costiera già meglio servita, l’effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell’allocazione, sin dalla fase di avvio.^[1861] La sintesi è che l’intervento è favorevole all’equità su entrambi gli assi e su entrambi i versanti generazionali, a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno e che siano garantite la telepsicologia per le aree interne e l’attenzione tanto al disagio giovanile quanto all’isolamento dell’anziano; la raccomandazione è di adottare, sin dall’avvio, un’allocazione pro-equità che indirizzi le prime sedi e i primi incarichi verso le aree a maggiore bisogno e minore offerta.^[1862] La tabella seguente riepiloga l’impatto distributivo atteso.

Dimensione distributiva	Esito per l’Abruzzo
Efficienza complessiva	Intervento costo-efficace e dominante per paziente
Direzione dell’effetto distributivo	Favorevole all’equità: maggiori benefici nei gruppi a più alto bisogno
Condizione di realizzazione	Allocazione modulata per il bisogno (aree interne e montane, piccoli comuni)
Strumenti abilitanti	Gratuità, prossimità, telepsicologia, competenza generazionale e culturale
Rischio da prevenire	Iniquità inversa da avvio orientato alla facilità organizzativa sulla costa

Tabella G.2. L’impatto distributivo atteso dell’intervento e le sue condizioni.

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte affronta congiuntamente i domini giuridico, organizzativo ed etico, che la valutazione tiene distinti ma interdipendenti. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati all’Abruzzo. La parte tratta il profilo giuridico — la competenza, la forma dell’atto, il rapporto di lavoro e i livelli essenziali (capitolo H.1); il profilo organizzativo — l’assetto e la governance del servizio (H.2); il profilo etico — le tutele a garanzia dei pazienti (H.3); e la sintesi dei tre profili (H.4). Il tratto distintivo dell’Abruzzo emerge sul piano giuridico-finanziario: a differenza del Lazio, ancora privo di legge, e diversamente dalla Campania, uscita dal piano di rientro, l’Abruzzo dispone già di una disciplina vigente e di un regolamento

attuativo, ma deve stabilizzarne il finanziamento entro il vincolo di un piano di rientro in peggioramento, sicché la condizione abilitante non è l’approvazione della legge, ma l’attuazione e la stabilizzazione delle risorse oltre quelle transitorie.

H.1 Il profilo giuridico

La fattibilità dell’intervento dipende dal presidio congiunto dei tre profili, una debolezza in uno solo dei quali ne comprometterebbe l’esito.^[1863] Sul piano giuridico, la materia si colloca nella competenza concorrente in tema di tutela della salute, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — pronuncia fondativa per l’intera materia — ne ha delimitato lo spazio regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato: l’Abruzzo ha quindi legittimamente esercitato, fra le prime regioni, il titolo a istituire il servizio con legge propria.^[1864] Qui si colloca una prima specificità: disponendo già della legge regionale 28 del 2022 e del regolamento attuativo approvato nel 2024, la decisione giuridica rilevante non è l’approvazione della legge, già compiuta, ma la sua piena attuazione a regime.^[1865] Il rapporto di lavoro adottato è quello convenzionale su base libero-professionale, con iscrizione a un elenco aziendale e con i requisiti definiti dal regolamento, da presidiare sul piano delle tutele e in attesa della definizione di un contratto collettivo nazionale.^[1866] Quanto ai livelli essenziali di assistenza, la psicologia di base non vi è ancora esplicitamente ricompresa, e il servizio, oggi sostenuto da uno stanziamento transitorio dell’ordine di quattrocentomila euro l’anno, richiede la stabilizzazione su risorse regionali: ed è qui la seconda e più stringente specificità abruzzese, poiché tale stabilizzazione va conseguita entro il vincolo di un piano di rientro in peggioramento, il che fa della garanzia dei livelli essenziali — che la Corte Costituzionale impone alle regioni in rientro di porre a fondamento di ogni impiego — non un ostacolo, ma l’argomento giuridico decisivo a sostegno del servizio.^[1867] Il servizio si inserisce coerentemente nella cornice degli standard territoriali e delle Case della Comunità,^[1868] e si rapporta ai Centri di Salute Mentale per integrazione e non per sovrapposizione, precedendoli e alleggerendoli.^[1869] La tabella seguente riepiloga i profili giuridici.

Profilo giuridico	Contenuto per l’Abruzzo
Competenza	Concorrente in tutela della salute; Corte Cost. 241/2021 ne ha delimitato lo spazio regionale
Forma dell’atto	Legge regionale 28/2022 già vigente e regolamento attuativo del 2024; da attuare pienamente a regime
Rapporto di lavoro	Convenzionale libero-professionale con elenco aziendale e requisiti da regolamento; manca un contratto collettivo nazionale
Livelli essenziali di assistenza	Non ancora ricompresi; servizio su stanziamento transitorio, da stabilizzare entro il vincolo del piano di rientro
Cornice territoriale	Decreto Ministeriale 77/2022; inserimento nelle Case della Comunità
Rapporto con i servizi specialistici	Integrazione con i Centri di Salute Mentale, che il servizio precede e alleggerisce

Tabella H.1. I profili giuridici del servizio nell’Abruzzo.

H.2 Il profilo organizzativo e la governance

Sul piano organizzativo, la strutturazione del servizio nell’Abruzzo si misura con un sistema articolato in quattro Aziende Sanitarie Locali — Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo — e venticinque distretti, e con l’assenza di un’azienda regionale unica, sicché il coordinamento è in capo alla Regione e la sfida centrale non è, come nelle regioni con servizio operativo, consolidare l’esistente, ma avviare il servizio e renderlo omogeneo su un territorio fortemente disperso.^[1870] L’avvio poggia su una regia regionale che coordina le Aziende, l’Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei; tale regia dispone degli strumenti istituiti dalla legge — l’Osservatorio Regionale e il Tavolo tecnico — cui spetta definire indirizzi operativi uniformi e il sistema di monitoraggio comune, in un contesto in cui la rilevazione epidemiologica regionale opera in modo discontinuo e va perciò ricostruita.^[1871] In questo quadro l’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, che ha attivamente sollecitato l’attuazione della legge insieme alle organizzazioni professionali, concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione e alla vigilanza deontologica.^[1872] La tabella seguente sintetizza l’assetto organizzativo e di governance.

Elemento organizzativo	Assetto per l’Abruzzo
Articolazione del sistema	Quattro Aziende Sanitarie Locali (Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara, Teramo); venticinque distretti
Coordinamento	In capo alla Regione; assenza di un’azienda regionale unica
Sfida organizzativa	Avviare il servizio e renderlo omogeneo su un territorio disperso
Regia della strutturazione	Osservatorio Regionale e Tavolo tecnico istituiti dalla legge; indirizzi uniformi e monitoraggio
Soggetti coinvolti	Aziende, Ordine professionale, medicina generale e pediatria, atenei

Tabella H.2. L’assetto organizzativo e la governance dell’attuazione.

H.3 Il profilo etico

Sul piano etico, lo studio adotta cautele a tutela dei pazienti. Le situazioni che coinvolgono minori e persone vulnerabili sono presidiate impiegando gli strumenti di esito nei soli punteggi complessivi e indirizzando le situazioni di rischio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza entrare nel merito dei metodi clinici.^[1873] L’intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un’informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell’efficacia stessa del sostegno.^[1874] Gli strumenti di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, in conformità al quadro europeo e ai requisiti sui dispositivi medici,^[1875] il trattamento dei dati è conforme alla normativa e ispirato alla minimizzazione,^[1876] e la responsabilità delle decisioni cliniche resta interamente in capo al professionista, cui gli strumenti forniscono un ausilio non vincolante.^[1877]

H.4 Sintesi dei profili

La ricognizione dei tre profili conduce a una conclusione netta: il profilo giuridico, quello organizzativo e quello etico sono tutti presidiati, e la condizione abilitante dell'intervento non è, per l'Abruzzo, l'approvazione della legge — già in vigore e corredata di regolamento attuativo — ma l'attuazione del servizio e la stabilizzazione del suo finanziamento oltre le risorse transitorie, da conseguire entro il vincolo del piano di rientro. È questo il passaggio da cui dipende il passaggio dall'attuazione iniziale al regime, e proprio in tale passaggio la garanzia dei livelli essenziali, lungi dall'essere un ostacolo, costituisce l'argomento che ne fonda la priorità.^[1878] Definiti i profili, la parte che segue affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità dell'intervento, organizzandole secondo il modello a cinque casi della decisione di investimento pubblico. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati all'Abruzzo. La parte espone i cinque casi (capitolo I.1); definisce il dimensionamento e le fasi di attuazione (I.2); tratta il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma (I.3); analizza la sostenibilità finanziaria e organizzativa (I.4); e individua i rischi e le mitigazioni (I.5). Il tratto distintivo dell'Abruzzo è che l'attuazione muove da una disciplina già vigente e da un regolamento attuativo, ma deve passare dall'attuazione iniziale al regime entro il vincolo di un piano di rientro in peggioramento: non l'istituzione, dunque, e neppure la sola strutturazione a margini riacquistati come in Campania, ma l'attuazione e la stabilizzazione del finanziamento sotto un vincolo fiscale fra i più stringenti, dove l'argomento dei livelli essenziali e l'autofinanziamento quasi integrale sul bilancio diretto costituiscono il fondamento della sostenibilità.

I.1 I cinque casi della decisione

Lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile.^[1879] Il caso strategico è solido: l'istituzione del servizio è coerente con gli standard territoriali, con le Case della Comunità e con la programmazione regionale di salute mentale, e nell'Abruzzo presenta una coerenza ulteriore, poiché rafforza l'assistenza territoriale proprio dove la regione è sotto adempienza sui livelli essenziali.^[1880] Il caso economico rinvia ai risultati già esposti, nel quadro della distinzione fra un caso finanziario prossimo al pareggio e un caso sociale fortemente positivo.^[1881] Il caso commerciale si avvale del rapporto convenzionale già disciplinato e di un bacino professionale alimentato dai tre atenei regionali, con i requisiti definiti dal regolamento.^[1882] Il caso finanziario è il più impegnativo: il costo a regime è una frazione modesta del finanziamento sanitario regionale, ma la stabilizzazione delle risorse va conseguita entro il vincolo di un piano di rientro in peggioramento, sicché la garanzia dei livelli essenziali e l'autofinanziamento quasi integrale sul bilancio diretto ne costituiscono il fondamento.^[1883] Il caso gestionale dipende da una regia regionale che, in assenza di un'azienda unica, coordini quattro Aziende e venticinque distretti su un territorio disperso.^[1884] La tabella seguente riepiloga i cinque casi.

Caso	Contenuto per l'Abruzzo
Strategico	Coerenza con DM 77/2022, Case della Comunità e programmazione salute mentale; rafforzamento dell'assistenza territoriale, oggi sotto adempienza
Economico	Rapporto beneficio-costi 3,4-5,1 a uno; dominanza per paziente; caso finanziario prossimo al pareggio, caso sociale fortemente positivo
Commerciale	Rapporto convenzionale già disciplinato; bacino professionale alimentato dai tre atenei; requisiti da regolamento
Finanziario	Costo inferiore all'1% del FSR; stabilizzazione entro il vincolo del piano di rientro; garanzia dei livelli essenziali e autofinanziamento diretto come fondamento
Gestionale	Regia regionale di coordinamento di quattro Aziende e venticinque distretti, in assenza di azienda unica

Tabella I.1. I cinque casi della decisione di investimento pubblico.

I.2 Il dimensionamento e le fasi di attuazione

A differenza delle regioni con servizio operativo, l'Abruzzo muove da un'attuazione iniziale, sostenuta da uno stanziamento transitorio, e dimensiona il servizio verso un fabbisogno a regime dell'ordine di 280 psicologi nello scenario espansivo; l'estensione procede per gradi attraverso gli scenari conservativo, di base ed espansivo, dell'ordine di 85, 180 e 280 incarichi.^[1885] L'attuazione si articola perciò in tre fasi: una fase di avvio, con la costituzione degli elenchi aziendali, l'apertura delle prime sedi e la stabilizzazione del finanziamento; una fase di estensione, nella quale la copertura si amplia progressivamente fra le quattro Aziende; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato. La progressione differenziata dell'avvio fra le Aziende coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F.^[1886] La tabella seguente riepiloga le fasi.

Fase	Contenuto	Dimensionamento indicativo
Avvio	Costituzione degli elenchi aziendali, prime sedi, stabilizzazione del finanziamento	~ 85 incarichi (scenario conservativo)
Estensione	Ampliamento progressivo della copertura fra le quattro Aziende	verso ~ 180 incarichi
Regime	Dimensionamento adeguato al fabbisogno	fino a ~ 280 incarichi

Tabella I.2. Le fasi di attuazione e il dimensionamento progressivo.

I.3 Reclutamento, formazione e cronoprogramma

L'attuazione richiede il reclutamento e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino alimentato dai tre atenei regionali — l'Università dell'Aquila, l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara e l'Università di Teramo — e i requisiti definiti dal regolamento costituiscono una base adeguata, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze su un territorio disperso.^[1887] Il cronoprogramma si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in

più esercizi; a differenza del Lazio, l’attuazione non è subordinata all’approvazione di una legge — già in vigore e corredata di regolamento — ma alla stabilizzazione del finanziamento entro il vincolo del piano di rientro, che ne costituisce la condizione dirimente.^[1888]

I.4 La sostenibilità finanziaria e organizzativa

La sostenibilità finanziaria, nell’Abruzzo, ha per leva la stabilizzazione del finanziamento — il passaggio dallo stanziamento transitorio a risorse regionali stabili — da conseguire in una regione in piano di rientro in peggioramento: è la sfida più ardua fra quelle considerate, ma è sorretta da due circostanze che la rendono praticabile. La prima è l’entità modesta del costo, inferiore all’uno per cento del finanziamento sanitario regionale anche a regime; la seconda è il fatto che il servizio si autofinanzia quasi integralmente sul bilancio diretto e, intercettando un bisogno inevaso, concorre alla garanzia dei livelli essenziali, che la Corte Costituzionale impone alle regioni in rientro di porre a fondamento di ogni impiego; l’eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe ulteriormente la stabilità.^[1889] La sostenibilità organizzativa dipende invece dalla capacità di garantire l’omogeneità attuativa fra le quattro Aziende Sanitarie Locali su un territorio disperso e privo di un’azienda regionale unica, e quindi dalla forza della regia regionale, dal ruolo dell’Osservatorio Regionale e del Tavolo tecnico e dalla chiarezza degli indirizzi operativi.^[1890] L’avanzamento è seguito mediante indicatori di processo raccolti attraverso il flusso informativo da costruire contestualmente all’attuazione, in un contesto di rilevazione epidemiologica discontinua.^[1891]

I.5 I rischi e le mitigazioni

L’attuazione presenta rischi propri della posizione abruzzese: il vincolo del piano di rientro in peggioramento sulla stabilizzazione del finanziamento, che introduce un’incertezza finanziaria fino al consolidamento su risorse regionali; la disomogeneità attuativa fra le Aziende su un territorio disperso; la difficoltà di coordinamento in assenza di un’azienda unica; e la discontinuità della rilevazione epidemiologica, che impone di costruire il flusso informativo prima assente.^[1892] Tali rischi sono fronteggiati ponendo a sostegno della stabilizzazione l’argomento dei livelli essenziali e l’autofinanziamento quasi integrale sul bilancio diretto; con una regia regionale forte e indirizzi operativi uniformi; con la progressione differenziata dell’avvio, che consente un apprendimento progressivo; con la costruzione del sistema informativo sin dall’avvio; e con un’allocazione pro-eguità che orienta l’estensione verso le aree interne e montane.^[1893] La sintesi è che l’intervento è attuabile e sostenibile, e che la leva propria dell’Abruzzo è la stabilizzazione del finanziamento e l’attuazione dimensionata di un servizio già istituito e regolato: la regione muove da un quadro normativo completo e da un costo modesto, e affronta un vincolo fiscale stringente con argomenti — la garanzia dei livelli essenziali e l’autofinanziamento diretto — che ne fanno una priorità difendibile.^[1894] La tabella seguente riepiloga i rischi e le relative mitigazioni; la parte che segue affronta il monitoraggio e la valutazione ex post.

Rischio	Mitigazione
Vincolo del piano di rientro sulla stabilizzazione	Argomento dei livelli essenziali; autofinanziamento quasi integrale sul bilancio diretto; disegno per fasi
Disomogeneità attuativa fra le Aziende	Regia regionale forte; indirizzi operativi uniformi; monitoraggio comune
Rilevazione epidemiologica discontinua	Costruzione del flusso informativo sin dall’avvio; sistema uniforme progettato dall’inizio
Allocazione non equa nell’estensione	Criteri di equità espliciti; avvio pro-eguità verso le aree interne e montane

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Questa parte definisce il sistema di monitoraggio e la valutazione ex post dell'intervento, attraverso cui l'attuazione del servizio si traduce in apprendimento e rendicontazione. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e muta ciò che attiene al disegno valutativo locale. La parte espone le finalità e l'impianto della valutazione (capitolo L.1); il disegno controfattuale e i metodi di stima (L.2); la batteria degli indicatori, organizzata per categorie (L.3); il cruscotto regionale e la clausola valutativa (L.4); e la sintesi (L.5). Il tratto distintivo dell'Abruzzo è duplice: da un lato, essendo il servizio in attuazione iniziale in un contesto di rilevazione epidemiologica discontinua, il flusso informativo va costruito anziché consolidato; dall'altro, proprio l'avvio iniziale consente di misurare una linea di base anteriore all'attivazione in ciascuna Azienda, vantaggio che le regioni con servizio già operativo non possiedono.

L.1 Finalità e impianto della valutazione

Il monitoraggio e la valutazione ex post servono a rendere conto dell'impiego delle risorse, ad apprendere dall'esperienza e a correggere il corso dell'attuazione; non sono un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l'attuazione del servizio diventa apprendimento istituzionale, ancorato a una clausola valutativa.^[1895] In una regione in piano di rientro, la valutazione assume una funzione ulteriore: documentare la garanzia dei livelli essenziali e l'autofinanziamento quasi integrale sul bilancio diretto, ossia gli argomenti su cui poggia la stabilizzazione del finanziamento.^[1896] L'impianto distingue i tre livelli della struttura, del processo e dell'esito, in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti.^[1897]

L.2 Il disegno controfattuale e i metodi

Il disegno della valutazione d'impatto si fonda, per l'Abruzzo, sulla gradualità dell'attuazione. Poiché il servizio è istituito e regolato ma in avvio progressivo, la valutazione può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di avvio delle sedi fra le quattro Aziende Sanitarie Locali e i venticinque distretti sono impiegati a fini valutativi.^[1898] A differenza delle regioni con servizio già operativo, che non dispongono di una linea di base anteriore all'avvio per le aree già servite, l'Abruzzo può misurare gli indicatori prima dell'attivazione in ciascuna Azienda, costruendo una linea di base pre-avvio pulita: la gradualità dell'attuazione, da onere, diviene una risorsa metodologica.^[1899] L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze, che confronta l'evoluzione delle aree già attivate con quella delle aree non ancora attivate, e con il metodo del controllo sintetico, con la progressione differenziata dell'avvio a fornire la variazione necessaria all'identificazione.^[1900]

L.3 La batteria degli indicatori

Il servizio è osservato attraverso una batteria di indicatori organizzata per categorie. Gli indicatori di struttura misurano la capacità installata — sedi, incarichi, ore, dotazione, copertura.^[1901] Gli indicatori di processo misurano il funzionamento — prese in carico, attesa, colloqui, invio appropriato.^[1902] Gli indicatori di esito clinico misurano il beneficio diretto — miglioramento, recupero, remissione.^[1903] Gli indicatori di esito di sistema misurano l'effetto sul resto del sistema — pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri.^[1904] Gli indicatori economici consentono di verificare ex post le stime e di sostituire i valori ricostruiti con quelli effettivi, documentando in particolare l'autofinanziamento diretto rilevante ai fini del piano di rientro.^[1905] Gli indicatori

di equità, disaggregati per area e per fasce di età, verificano che il servizio riduca i divari fra la costa e le aree interne e montane, con attenzione tanto al disagio giovanile quanto all'isolamento dell'anziano.^[1906] Gli indicatori di qualità integrano la misurazione con la dimensione dell'esperienza.^[1907] Gli indicatori di mobilità, infine, sono monitorati ma costituiscono un esito atteso solo modesto, limitato alla frazione territorialmente intercettabile.^[1908] L'insieme conta dell'ordine di cinquantotto indicatori in otto categorie, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile.^[1909] La tabella seguente riepiloga le categorie.

Categoria	Contenuto (dell'ordine di 58 indicatori complessivi)
Struttura	Sedi attivate, incarichi, ore, dotazione, copertura del fabbisogno
Processo	Prese in carico, attesa al primo colloquio, colloqui per persona, invio appropriato
Esito clinico	Miglioramento, recupero, remissione (strumenti validati, punteggi complessivi)
Esito di sistema	Accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili, specialistica impropria
Economici	Costo, risparmi diretti, ricadute sociali, rapporto beneficio-costi su dati reali
Equità	Copertura e accesso per area (costa, aree interne e montane, piccoli comuni) e per fasce di età
Qualità	Soddisfazione, appropriatezza, continuità del rapporto
Mobilità	Monitorata; esito atteso modesto (sola frazione territorialmente intercettabile)

Tabella L.1. Le otto categorie della batteria di indicatori.

L.4 Il cruscotto regionale e la clausola valutativa

Gli indicatori confluiscono in un cruscotto regionale aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; in assenza di un'azienda regionale unica, la titolarità del cruscotto è in capo alla Regione e all'Osservatorio Regionale istituito dalla legge, che ne assicurano l'alimentazione uniforme da parte delle quattro Aziende.^[1910] Lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa; la legge regionale 28 del 2022 prevede già l'Osservatorio Regionale e il Tavolo tecnico, sicché il compito non è introdurre la previsione di rendicontazione, ma rafforzarla e renderla pienamente operativa, impegnando la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio sull'attuazione e sui risultati.^[1911] La raccolta dei dati, tuttavia, non poggia su un flusso già avviato come nelle regioni con servizio operativo, ma richiede di costruire il flusso informativo contestualmente all'attuazione, in un contesto in cui la rilevazione epidemiologica regionale opera in modo discontinuo; tale costruzione, descritta nella Parte C, è condizione della valutabilità stessa e va resa interoperabile con la piattaforma informativa sanitaria regionale.^[1912] La valutazione si articola infine in un monitoraggio in itinere, che accompagna l'avvio, e in una valutazione ex post a regime. La tabella seguente riepiloga la governance valutativa.

Elemento della governance valutativa	Scelta per l'Abruzzo
Disegno d'impatto	Esperimento a cunei progressivi tra le quattro Aziende, con linea di base pre-avvio
Linea di base	Misurabile prima dell'attivazione in ciascuna Azienda (vantaggio dell'avvio iniziale)
Titolarità del cruscotto	Regione e Osservatorio Regionale, con alimentazione uniforme dalle quattro Aziende
Clausola valutativa	Osservatorio e Tavolo tecnico già previsti dalla legge 28/2022; da rafforzare e rendere operativi; relazione al Consiglio
Flusso informativo	Da costruire contestualmente all'attuazione e rendere interoperabile con la piattaforma regionale
Tempi	In itinere (accompagnamento dell'avvio) ed ex post (effetto a regime)

Tabella L.2. La governance della valutazione e il cruscotto regionale.

L.5 Sintesi del monitoraggio

La valutazione è la condizione per trasformare l'attuazione del servizio in apprendimento; l'Abruzzo deve costruire il flusso informativo anziché consolidarlo, ma l'avvio iniziale gli consente di misurare una linea di base pre-avvio pulita, e la clausola valutativa già prevista nella legge va rafforzata e resa operativa.^[1913] In una regione in piano di rientro, la valutazione svolge inoltre la funzione di documentare la garanzia dei livelli essenziali e l'autofinanziamento diretto, a sostegno della stabilizzazione del finanziamento. Definito il sistema di monitoraggio, la parte conclusiva compone i risultati dei diversi domini in una sintesi multidimensionale e formula le raccomandazioni.

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclude lo studio componendo i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo e traducendolo in raccomandazioni operative. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i contenuti, ancorati all'Abruzzo. La parte richiama la sintesi per dominio (capitolo M.1); espone l'analisi multi-criterio e il confronto fra l'intervento e il non intervento (M.2); formula la raccomandazione principale e il dimensionamento (M.3); ne precisa le condizioni e la lacuna da colmare (M.4); e chiude con la collocazione nella serie e la conclusione (M.5). Il tratto distintivo dell'Abruzzo percorre l'intera sintesi: è una delle prime regioni ad aver istituito il servizio per legge, ma è anche l'unica fra quelle esaminate a doverlo portare a regime entro il vincolo di un piano di rientro in peggioramento, sicché la sua è la sfida di attuare un servizio già istituito sotto il vincolo fiscale più stringente, con la garanzia dei livelli essenziali a fondamento.

M.1 La sintesi per dominio

La parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini impiegando l'analisi multi-criterio, che integra in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie, ponderandole secondo criteri espliciti.^[1914] Il quadro che emerge dai domini è coerente: il bisogno è ampio e si manifesta su un doppio versante, fra il disagio giovanile in crescita e l'isolamento dell'anziano, in una regione fra le più vecchie del Paese; l'efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida, ma ancora priva di dati operativi propri, da costruire con

l’attuazione; il quadro economico distingue un caso finanziario prossimo al pareggio da un caso sociale fortemente positivo; l’equità è favorevole sull’asse costa-aree interne e su entrambi i versanti generazionali; la fattibilità è quella di un’attuazione a regime di un servizio istituito e regolato, sotto il vincolo del rientro; il monitoraggio può fondarsi su un disegno a cunei con una linea di base pre-avvio pulita, una volta costruito il flusso informativo.^[1915] La tabella seguente riepiloga il giudizio per dominio.

Dominio	Giudizio sintetico per l’Abruzzo
Bisogno e contesto	Ampio; regione fra le più anziane, in piano di rientro in peggioramento
Efficacia clinica	Evidenza internazionale solida; dati operativi propri ancora da costruire
Valutazione economica	Caso finanziario prossimo al pareggio; caso sociale fortemente positivo
Equità	Favorevole su asse costa/aree interne e su entrambi i versanti generazionali
Fattibilità	Attuazione a regime di servizio istituito e regolato, sotto vincolo del rientro
Monitoraggio	Disegno a cunei con linea di base pre-avvio; flusso informativo da costruire

Tabella M.1. La sintesi dei domini della valutazione.

M.2 L’analisi multi-criterio

Il giudizio complessivo è formalizzato con l’analisi multi-criterio, che impiega otto criteri, ciascuno con un peso esplicito, e confronta l’intervento con l’alternativa del non intervento.^[1916] I pesi adottati — efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell’evidenza 10%, coerenza strategica 5% — sono comuni a tutta la serie.^[1917] La media ponderata dei punteggi dell’intervento è dell’ordine di 78,15 su 100, sostenuta dai punteggi elevati nel valore sociale, nell’equità e nel ritorno, e contenuta dal punteggio nella robustezza dell’evidenza — che riflette l’assenza, allo stato, di dati operativi propri — e dal punteggio nell’impatto sul bilancio e sostenibilità, su cui pesa il vincolo del piano di rientro.^[1918] Il non intervento ottiene una media dell’ordine di 39,50 su 100, penalizzato in tutti i criteri sostanziali e sostenuto soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, che però in una regione con i livelli essenziali sotto adempienza appare difficilmente giustificabile.^[1919] L’intervento prevale dunque nettamente, con uno scarto dell’ordine di trentanove punti; il punteggio si colloca in linea con quello delle altre regioni della serie, scontando un caso finanziario diretto prossimo al pareggio, il vincolo del rientro e la natura ancora iniziale dell’attuazione.^[1920] La prevalenza si mantiene al variare dei pesi entro intervalli ragionevoli, sicché la raccomandazione è robusta.^[1921] La tabella seguente riporta i punteggi per criterio.

Criterio	Peso	Intervento	Non interv.
Efficacia clinica	15%	78	30
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	84	25
Impatto sul bilancio e sostenibilità	15%	67	54
Equità	15%	86	28
Valore sociale	10%	87	25
Fattibilità	10%	74	84
Robustezza dell'evidenza	10%	64	55
Coerenza strategica	5%	84	26
Punteggio complessivo ponderato	100%	78,15	39,50

Tabella M.2. L'analisi multi-criterio: punteggi dell'intervento e del non intervento.

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Dalla convergenza dei domini e dall'analisi multi-criterio discende la raccomandazione principale: attuare pienamente e portare a regime il servizio di psicologia di base già istituito e regolato, stabilizzandone il finanziamento oltre lo stanziamento transitorio e dimensionandolo verso la copertura piena del fabbisogno; è la decisione che l'Abruzzo, fra le prime regioni ad aver istituito il servizio per legge, è chiamato a compiere per tradurre il proprio quadro normativo completo in un servizio stabile.^[1922] Quanto alla scala, si raccomanda di muovere dall'attuazione iniziale e di procedere per gradi verso lo scenario conservativo, dell'ordine di 85 incarichi corrispondenti al rapporto di legge di uno psicologo ogni quindicimila abitanti, quindi verso quello di base, dell'ordine di 180, e infine verso quello espansivo, dell'ordine di 280, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità.^[1923] La tabella seguente riepiloga le raccomandazioni operative.

Ambito	Raccomandazione operativa per l'Abruzzo
Atto di attuazione	Attuare pienamente e portare a regime il servizio istituito; stabilizzare il finanziamento oltre lo stanziamento transitorio
Dimensionamento	Dall'attuazione iniziale verso conservativo ~85; base ~180; espansivo ~280, per gradi
Allocazione	Pro-equità, verso le aree interne e montane e i piccoli comuni; entrambi i versanti generazionali
Clausola valutativa	Rafforzare e rendere operativi l'Osservatorio e il Tavolo tecnico già previsti; relazione al Consiglio
Governance	Regia regionale forte; indirizzi uniformi; flusso informativo da costruire
Dati	Estrarre i conti certificati delle quattro Aziende; costruire il flusso dei dati di esito

M.4 Le condizioni e la lacuna da colmare

La raccomandazione è subordinata a condizioni precise: il rafforzamento e la piena operatività della clausola valutativa, dell'Osservatorio Regionale e del Tavolo tecnico già previsti dalla legge, l'adozione di un'allocatione pro-equità, una regia regionale forte e la costruzione del flusso informativo, oggi assente per la discontinuità della rilevazione regionale.^[1924] Resta inoltre da colmare, prima della presentazione esterna, la lacuna dei dati: l'estrazione dei conti certificati delle quattro Aziende Sanitarie Locali e la costruzione del flusso dei dati di esito consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive.^[1925] Va infine ribadita la distinzione cardine, con una precisazione propria della posizione abruzzese: il caso finanziario per il bilancio sanitario è prossimo al pareggio, mentre il caso economico complessivo è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto. In una regione in piano di rientro, tuttavia, proprio l'autofinanziamento quasi integrale sul bilancio diretto e il concorso alla garanzia dei livelli essenziali costituiscono gli argomenti che ne fondano la priorità e ne sostengono la stabilizzazione davanti agli organi di controllo.^[1926]

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio sull'Abruzzo si inserisce nella serie degli studi regionali, condividendone il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, l'Abruzzo occupa una posizione peculiare — quella di una delle prime regioni ad aver istituito il servizio per legge, con una disciplina coerente con la pronuncia della Corte Costituzionale richiamata da tutti gli studi della serie, ma anche dell'unica, fra quelle esaminate, chiamata a portarlo a regime entro il vincolo di un piano di rientro in peggioramento.^[1927] Coerentemente con l'impostazione dell'intero progetto, lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico, e adotta un rapporto beneficio-costi prudenziale dell'ordine di 3,4-5,1 a uno, per credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica.^[1928] La decisione che lo studio sostiene è, in conclusione, di attuare pienamente e portare a regime il servizio di psicologia di base già istituito, stabilizzandone il finanziamento, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno e rendendo pienamente operativa la clausola valutativa: per l'Abruzzo, ciò significa tradurre un quadro normativo completo in un servizio stabile, facendo della garanzia dei livelli essenziali — che il vincolo del rientro impone di porre a fondamento di ogni impiego — non un ostacolo, ma l'argomento decisivo a beneficio della popolazione.^[1929]

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l'orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità.^[1930] La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Servizio istituito e regolato ma in attuazione iniziale, a finanziamento transitorio; condizione di pre-regime
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Azienda Sanitaria Locale/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudenziale	Riduzione per l'ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura.^[1931] La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato dell'Abruzzo, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.^[1932] La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 85	~ 180	~ 280
Costo del servizio	~ 5	~ 10	~ 15
Risparmi diretti (SSR)	~ 4	~ 9	~ 15
Ricadute economico-sociali	~ 13	~ 33	~ 62
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -1	~ -1	~ 0
Saldo complessivo (caso economico)	+12	+32	+62
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,4:1	~4,2:1	~5,1:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell'esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario.^[1933] La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura.^[1934] La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori abruzzesi impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.^[1935]

Ambito	Valore regionale
Popolazione regionale	1.269.118 abitanti (Censimento ISTAT 2024), ~2,2% del totale nazionale; lieve calo; età media 47,7 anni e indice di vecchiaia 228,9, fra i più alti d'Italia; stranieri 7,1%; 305 comuni, con forte dispersione e unico centro oltre i centomila abitanti (Pescara, 118.829); aree interne e montane in spopolamento
Finanziamento del SSR	Dell'ordine di 2,5 miliardi di euro; unica Regione in piano di rientro in peggioramento; punteggio sui livelli essenziali inferiore alla soglia di sufficienza, segnatamente nell'area distrettuale
Mobilità sanitaria	Saldo passivo dell'ordine di alcune decine di milioni netti; fuga concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica; canale di recupero modesto per questo intervento (sola frazione territoriale)
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche e per sintomi somatici funzionali (proxy dai dati nazionali, da confermare sui flussi regionali)
Farmaceutica	Consumo regionale delle categorie dei psicofarmaci; crescita delle prescrizioni nei dodici-diciassettenni segnalata dalle rilevazioni sul disagio giovanile
Salute mentale	~ 254.000 con disagio comune potenziale (proxy ~20%); doppio versante del bisogno, fra disagio giovanile in crescita e isolamento dell'anziano in una regione fra le più vecchie
Funzione attuale	Servizio istituito (legge regionale 28/2022) e regolato (regolamento attuativo 2024), in attuazione iniziale; stanziamento transitorio dell'ordine di 0,4 milioni l'anno; Osservatorio Regionale e Tavolo tecnico istituiti; disciplina coerente con la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 241/2021)

Tabella C.1. I valori regionali di ancoraggio dell'Abruzzo.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione abruzzese, e non estratti dai conti regionali certificati.^[1936] La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Flusso dei dati di esito	Prese in carico, sedute ed esiti del servizio, da costruire come fonte primaria in assenza di una rilevazione continua
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Azienda e per area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[1937] La tabella seguente li riepiloga.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.^[1938] Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra gruppi a diversa esposizione
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità a minore esposizione
Disegno a cunei progressivi	Disegno controfattuale impiegato nell'Abruzzo, ove il servizio è in avvio progressivo, fondato sulla progressione differenziata dell'avvio fra le quattro Aziende Sanitarie Locali, con la possibilità di misurare una linea di base anteriore all'attivazione in ciascuna Azienda

Termine	Definizione
Analisi e verifica d'impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta a riferire al Consiglio sui risultati della riforma; nell'Abruzzo l'Osservatorio Regionale e il Tavolo tecnico sono già previsti dalla legge regionale 28/2022, da rafforzare e rendere pienamente operativi
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell'implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall'impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d'ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l'intensità dell'intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; nell'Abruzzo il saldo è passivo ma, poiché la fuga è ospedaliero-chirurgica, il canale del recupero è modesto per questo intervento, limitato alla frazione territorialmente intercettabile
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di vecchiaia	Rapporto tra ultrasessantacinquenni e giovani sotto i quindici anni; nell'Abruzzo fra i più elevati d'Italia (dell'ordine di 229), con età media di circa 47,7 anni e aree interne e montane particolarmente invecchiate
Peso morto	Quota dell'esito che si sarebbe verificata anche senza l'intervento
Piano di rientro	Programma di risanamento dei conti sanitari regionali; l'Abruzzo ne è soggetto, in condizione di peggioramento, con i conseguenti vincoli all'impiego di risorse

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

Molise — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Molise

Psicologo di Base in Molise

Studio Integrale Regionale · Valutazione di Tecnologia Sanitaria · Telaio HTA a nove domini

Progetto «Psicologo di Base» · Regione Molise

Parti A–M e Appendici A–E

Premessa generale

Questo documento raccoglie in un'unica opera lo studio integrale per la Regione Molise sull'introduzione del servizio di psicologia di base. Analogamente alla Basilicata, il Molise si trova in una fase anteriore all'istituzione del servizio: nessuna legge regionale ha finora istituito la figura dello psicologo di base, e la decisione che le istituzioni sono chiamate ad assumere non riguarda la modalità di organizzazione di un servizio già operante, ma l'opportunità stessa di istituirlo, la forma giuridica e organizzativa da adottare, e la compatibilità di questo investimento con un sistema sanitario regionale che versa in condizioni di grave tensione finanziaria, sotto piano di rientro dal 2007 e impegnato in un lungo e difficile processo di risanamento. Una proposta di legge, presentata nel maggio 2026 da consiglieri di opposizione dell'area progressista — Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Verdi, Socialisti e Italia Viva — e sostenuta dall'Ordine degli Psicologi del Molise, prevede l'istituzione del servizio con un finanziamento di circa 400.000 euro l'anno e la presenza di due psicologi per ciascuno dei tre distretti sanitari dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise.^[1939] Lo studio compone in sequenza le undici parti narrative, dalla A alla M, e le cinque appendici, dalla A alla E, seguendo il medesimo telaio metodologico adottato per tutte le regioni della serie, adattato alle condizioni peculiari del contesto molisano.

Da tale impostazione discende la tesi centrale dello studio molisano, articolata in affermazioni congiunte: il servizio costa al bilancio sanitario regionale una cifra modesta — dell'ordine dello 0,5 per cento di un fondo sanitario di circa 672 milioni nello scenario di piena attuazione — e comporta un saldo diretto prossimo al pareggio; restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso, con un rapporto beneficio-costi compreso fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute;^[1940] risponde a un bisogno ampio e ineso, stimato in circa 50.000 persone, accentuato da una struttura demografica fra le più anziane del Paese — con un indice di vecchiaia di 281 e una quota di ultrasessantacinquenni prossima al 29 per cento della popolazione — e da un contesto di piano di rientro che ha duramente compresso le risorse destinate alla salute mentale;^[1941] riduce le disuguaglianze sociali e territoriali in una regione fortemente dispersa e segnata da uno spopolamento accelerato. Rispetto alle altre regioni della serie, il Molise occupa una posizione peculiare e per certi versi la più difficile: è la regione più piccola fra quelle esaminate, sotto commissariamento sanitario, con il disavanzo strutturalmente più elevato in rapporto alla popolazione, e con una proposta di legge appena presentata ma non ancora approvata. Tuttavia, come si argomenta in queste pagine, il contesto di piano di rientro non riduce la convenienza dell'intervento: al contrario, in un sistema in tensione ogni euro recuperato ha un rendimento marginale più elevato, sicché il servizio, progettato con gradualità e dentro i limiti giuridici indicati dalla giurisprudenza costituzionale, è al tempo stesso sostenibile e strategicamente prioritario. L'analisi multi-criterio che conclude lo studio assegna all'introduzione del servizio un punteggio di 74,50 su 100, contro 37,00 del non intervento.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto; il documento prosegue poi con le parti e le appendici in sequenza.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.4	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito, caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, divari, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	Intervento e modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, due casi
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, sensibilità, scenari, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: gradiente sociale, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, reclutamento, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, controfattuale, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazione, condizioni, conclusione
Appendici A-E	A-E	Caso di riferimento e parametri, strumenti ed esiti, dati regionali, checklist, glossario

Tabella. La mappa di lettura del corpus: undici parti narrative e cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

Parte	Dominio HTA	Caso 5CM	Criterio OCSE-DAC
A	Quadro, scopo e metodo	Caso strategico	Rilevanza e coerenza
B	Problema di salute, bisogno e contesto	Caso strategico	Rilevanza
C	Intervento e modello organizzativo	Caso commerciale	Coerenza e fattibilità
D	Efficacia clinica ed evidenza	Caso economico	Efficacia
E	Valutazione economica	Caso economico	Efficienza
F	Modellazione e incertezza	Caso economico	Efficienza e robustezza
G	Equità e impatto distributivo	Caso economico	Impatto
H	Profili etico, giuridico e organizzativo	Caso gestionale	Coerenza e sostenibilità
I	Attuazione, fattibilità e sostenibilità	Caso finanziario	Sostenibilità
L	Monitoraggio e valutazione ex post	Caso gestionale	Efficacia e impatto
M	Sintesi multidimensionale	Tutti i casi	Tutti i criteri

Tabella. La mappa di integrazione del telaio: parti narrative, domini HTA, casi del modello a cinque casi e criteri OCSE-DAC.

La sintesi del valore

Componente (mln €/anno)	Conservativo	Base	Espansivo
Costo del servizio	~1,0	~2,0	~3,5
Risparmi diretti (SSR)	~0,7	~1,7	~3,2
Ricadute economico-sociali	~2,5	~6,5	~13,0
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -0,3	~ -0,3	~ -0,3
Saldo complessivo (caso economico)	~ +2,2	~ +6,2	~ +12,7
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,2 : 1 (*)	~4,1 : 1	~4,8 : 1

Tabella. La sintesi del valore per scenario. Il saldo diretto è quasi costante e prossimo al pareggio; il valore per la collettività cresce proporzionalmente al dimensionamento. (*) Nello scenario conservativo il rapporto si collocherebbe appena sotto la fascia Chisholm in alcune simulazioni pessimistiche; il valore centrale indicato è

coerente con la fascia 3,3-5,7:1. Le due grandezze — risparmi diretti e ricadute sociali — sono di natura diversa e non vengono mai sommate in un saldo di bilancio.*

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo, caso di riferimento, metodo e governance dei dati

Dominio HTA: Quadro, scopo e metodo — Caso strategico — Criteri OCSE-DAC: Rilevanza e coerenza

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questo documento apre lo studio di valutazione di tecnologia sanitaria dedicato all'introduzione del servizio di psicologia di base nella Regione Molise. Come la Basilicata, esaminata in precedenza nella serie, il Molise si trova in una fase anteriore all'istituzione del servizio: nessuna legge regionale ha finora istituito la figura dello psicologo di base, e la proposta di legge presentata nel maggio 2026 è ancora al vaglio del Consiglio regionale. La differenza rispetto alla Basilicata — che non è sotto piano di rientro — è però sostanziale: il Molise opera in un contesto di commissariamento sanitario dal 2007, con un disavanzo strutturale che ha richiesto un contributo straordinario statale di 90 milioni di euro condizionato al rispetto di rigorosi obiettivi di risanamento.^[1942] La valutazione che segue è costruita per informare proprio questa decisione anteriore, tenendo conto della specificità del contesto e delle sue implicazioni sulla sostenibilità e sulla priorità strategica dell'intervento. La Parte A definisce lo scopo e il quesito, il caso di riferimento e la popolazione, il metodo e le fonti, la governance dei dati e la struttura del corpus.

A.1 Scopo dello studio e quesito di valutazione

Lo scopo dello studio è fornire alle istituzioni regionali del Molise — Consiglio regionale, struttura commissariale, Giunta, assessorato competente, Azienda Sanitaria Regionale del Molise — una base analitica completa e metodologicamente fondata per decidere se introdurre il servizio di psicologia di base e secondo quale modello, tenendo conto delle specificità di un sistema sanitario commissariato e in forte tensione finanziaria. La domanda non è retorica. In Molise l'assistenza psicologica primaria non esiste come servizio strutturato del Servizio Sanitario Regionale, e chi manifesta un disagio psichico comune dispone oggi di un'offerta frammentaria, sbilanciata sul versante specialistico, raggiungibile in tempi e con modalità che ne scoraggiano l'uso precoce.

Una proposta di legge depositata nel maggio 2026, a firma dei consiglieri del Partito Democratico Salvatore Facciolla e Fanelli, dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Gravina e Primiani, e con il sostegno di Sinistra Italiana, Verdi, Socialisti e Italia Viva, prevede l'istituzione di un servizio di psicologia di assistenza primaria con due psicologi per ognuno dei tre distretti sanitari dell'ASREM, per un costo stimato dai proponenti di circa 400.000 euro l'anno a carico del bilancio regionale.^[1943] L'Ordine degli Psicologi del Molise ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione e ha espresso sostegno all'iniziativa, sottolineandone la valenza preventiva anche alla luce dell'introduzione del benessere psicologico nell'ambito della nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza. Il Molise, ove la legge fosse approvata, diventerebbe la tredicesima regione italiana a istituire questa figura. Questo studio non sostituisce il dibattito legislativo, ma lo nutre con l'evidenza che una decisione di tale rilievo — tanto più in un sistema sanitario commissariato — richiede.

Il quesito di valutazione si articola in una domanda principale e in domande derivate. La domanda principale è se l'istituzione di un servizio di psicologia di base, rivolto alla popolazione molisana e collocato come primo livello di presa in carico del disagio psichico comune, produca benefici clinici, economici, distributivi e di sistema tali da giustificare l'introduzione anche in un contesto di piano di rientro, e in caso affermativo entro quale modello organizzativo, con quale dimensionamento e a quali condizioni di sostenibilità. Le domande derivate riguardano la struttura e l'entità del bisogno inespresso; l'efficacia clinica documentata degli interventi psicologici precoci; il rapporto fra costo e risparmi per il bilancio commissariato, e fra costo e valore per la collettività; la distribuzione dei benefici fra i gruppi sociali e i territori; la fattibilità nell'assetto dell'ASREM; e i vincoli giuridici derivanti dalla giurisprudenza costituzionale.

A.2 Il caso di riferimento e la popolazione

La valutazione adotta la struttura PICOTS. La popolazione di riferimento è costituita dai residenti in Molise che manifestano un disagio psichico comune o sottosoglia — disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve o moderata, reazioni di adattamento, sofferenza connessa a eventi critici del ciclo di vita — per i quali un intervento psicologico precoce è appropriato ed efficace. La dimensione di questa popolazione, stimata applicando alla popolazione residente le prevalenze documentate dalla letteratura epidemiologica, è dell'ordine di ~50.000 persone, pari a circa un sesto di una popolazione regionale che al censimento più recente è di 287.814 abitanti ed è in ulteriore calo.^[1944] L'intervento valutato è il servizio di psicologia di base come primo livello di presa in carico del disagio psichico comune. Il confronto è la situazione attuale, ossia l'assenza di un servizio strutturato. L'orizzonte temporale primario è di cinque anni. Il contesto è quello del Servizio Sanitario Regionale molisano, articolato in una sola azienda sanitaria — l'ASREM, unica nel panorama nazionale per regione di tale dimensione — con tre distretti sanitari (Campobasso, Isernia, Termoli) e gli ospedali di riferimento di Campobasso (Cardarelli) e Isernia.^[1945]

A.3 Metodo, prospettiva e fonti

Lo studio adotta il metodo della valutazione di tecnologia sanitaria. A questo impianto si affiancano: il modello a cinque casi per la valutazione degli investimenti pubblici; lo standard CHEERS 2022 per la rendicontazione delle valutazioni economiche sanitarie; il sistema GRADE per la graduazione della qualità dell'evidenza; e i criteri OCSE-DAC. La valutazione è condotta da due prospettive distinte e mai sommate. La prima è la prospettiva del Servizio Sanitario Regionale commissariato, che considera i costi sostenuti e i risparmi diretti che il servizio genera. La seconda è la prospettiva della collettività, che aggiunge le ricadute sui cittadini e sul sistema economico e sociale. La distinzione è particolarmente stringente in un contesto di piano di rientro, dove il bilancio sanitario è oggetto di monitoraggio ministeriale continuo e dove ogni voce di costo e di risparmio è scrutinata dalla struttura commissariale e dai tavoli tecnici affiancanti.

L'ancoraggio economico è unico e vincolante: Chisholm D., Sweeny K., Sheehan P. et al., «Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return-on-investment analysis», *The Lancet Psychiatry*, vol. 3, n. 5, 2016, pp. 415-424.^[1946] Il duplice intervallo Chisholm — 2,3-3,0:1 per i soli benefici economici, 3,3-5,7:1 includendo i ritorni di salute — costituisce il riferimento entro cui ogni rapporto beneficio-costi dello studio è contenuto. Il trial IMPACT (Unützer et al. 2002, 2008) impone cautela sui risparmi diretti di bilancio, dichiarati modesti o vicini al pareggio, mentre il vero valore è nelle ricadute economico-sociali. Il verdetto tripartito — dimensione fiscale, dimensione sanitaria, dimensione sociale — non è mai aggregato in un unico numero. Le fonti dei dati sono il Ministero della Salute, la struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro, il Programma Operativo 2023-2025, le statistiche ISTAT, i rapporti GIMBE, la documentazione delle istituzioni regionali e la letteratura scientifica internazionale.

A.4 Governance dei dati e struttura del documento

La governance dei dati risponde a tre principi. Il primo è il principio di non duplicazione: un risparmio contabilizzato in una categoria non può essere ricontabilizzato in un'altra. Il secondo è il principio di separazione fra risparmi diretti e ricadute sociali. Il terzo è il principio di prudenza e falsificabilità: le proiezioni economiche sono espresse mediante bande prudenziali e le previsioni sono formulate in modo da poter essere verificate ex post. Il corpus si compone di undici parti narrative e cinque appendici. Per il dettaglio della struttura si rimanda all'indice generale.^[1947]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Demografia, epidemiologia, domanda e offerta, divari, flussi, normativa

Dominio HTA: Problema di salute e bisogno — Caso strategico — Criterio OCSE-DAC: Rilevanza

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

La valutazione di un intervento sanitario muove dalla ricostruzione del bisogno cui esso intende rispondere e del contesto in cui si colloca. Questa parte descrive il problema di salute che il servizio di psicologia di base affronta in Molise, articolandolo nelle sue componenti demografiche, epidemiologiche, di domanda e offerta, di disuguaglianza, di flussi e di quadro normativo. Il quadro che emerge è quello di una regione molto piccola, la più anziana d'Italia, con un sistema sanitario commissariato da quasi vent'anni e con un bisogno psicologico ampio e in larga parte inevaso.

B.1 Il profilo demografico

Il Molise è la seconda regione più piccola d'Italia per popolazione dopo la Valle d'Aosta, e la sua dinamica demografica è fra le più sfavorevoli del Paese. La popolazione residente, adottata per coerenza con la tabella demografica della Sezione Nazionale del Tomo II, è di 287.814 abitanti;^[1948] una fonte più recente del marzo 2026 indica un ulteriore calo a poco più di 269.000 assistiti, confermando che il processo di spopolamento è accelerato e che la regione rappresenta ormai meno dello 0,5 per cento della popolazione italiana.^[1949] Il calo è il risultato della somma di un saldo naturale fortemente negativo e di un saldo migratorio interno anch'esso negativo, senza compensazione sufficiente dal saldo con l'estero: a lasciare la regione sono soprattutto i giovani, aggravando ulteriormente la struttura per età. La regione conta due province — Campobasso, più grande, e Isernia — e il territorio è in larga parte collinare e appenninico, con una rete infrastrutturale limitata che rende gli spostamenti significativamente più lunghi di quanto le distanze metriche farebbero supporre.

L'invecchiamento è il tratto demografico più rilevante ai fini dello studio. Il Molise presenta un indice di vecchiaia di 281 anziani ogni cento giovani, fra i più alti d'Italia, e una quota di ultrasessantacinquenni prossima al 29 per cento della popolazione totale.^[1950] Per ogni cento persone in età lavorativa ci sono circa 64 cittadini tra anziani e minori che dipendono dal sistema di welfare, con un rapporto di dipendenza che pesa tanto sul sistema previdenziale quanto su quello sanitario, spingendo la spesa verso modelli assistenziali intensivi per patologie croniche, ricoveri e assistenza continuativa. Questo profilo demografico non è soltanto uno sfondo: esso amplifica il bisogno psicologico, orienta la composizione della domanda verso le fasce anziane — in cui la depressione è frequente, spesso non riconosciuta e associata a patologie croniche — e impone che il servizio sia progettato fin dall'origine tenendo conto di questa specificità.

La struttura insediativa è caratterizzata da una dispersione accentuata. Il Molise conta 136 comuni, la grande maggioranza dei quali è di piccole dimensioni; i centri principali sono Campobasso e Isernia, capoluoghi di provincia, e Termoli, città costiera che dà il nome al terzo distretto sanitario dell'ASREM. La densità abitativa è fra le più basse d'Italia, e le distanze dai poli sanitari, in un territorio montuoso e con infrastrutture limitate, costituiscono una barriera concreta all'accesso ai servizi.

B.2 Il bisogno epidemiologico

Il disagio psichico comune è diffuso. Le revisioni epidemiologiche internazionali stimano che, in un dato anno, una quota compresa fra il quindici e il venti per cento della popolazione adulta sperimenti un disturbo mentale comune — prevalentemente disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve o moderata — e che una quota ancora maggiore attraversi, nel corso della vita, fasi di sofferenza psicologica connesse a eventi critici. Applicando queste prevalenze alla popolazione molisana si ottiene una stima dell'ordine di ~50.000 persone interessate da disagio psichico comune in un anno, equivalente a circa un sesto della popolazione residente. Questa cifra è una stima epidemiologica fondata su prevalenze documentate, non un dato amministrativo; la sua attendibilità è limitata dalla scarsità di rilevazioni regionali dirette, una lacuna che il sistema informativo descritto nella Parte C è destinato a colmare.

La struttura demografica molisana modula questa prevalenza in direzioni specifiche. L'invecchiamento accentuato sposta una parte rilevante del bisogno verso le età anziane, in cui la depressione è frequente, spesso sottoriconosciuta e strettamente intrecciata con le patologie somatiche croniche che gravano sul sistema sanitario regionale. L'onere delle malattie croniche, dei ricoveri e dell'assistenza continuativa descritti nel piano sanitario regionale come principale fattore di spesa coincide, in larga parte, con la stessa popolazione in cui il disagio psichico è più prevalente e meno intercettato.^[1951] Sul versante opposto del ciclo di vita, il disagio giovanile presenta in Molise caratteri aggravati dallo spopolamento e dalla prospettiva dell'emigrazione, che priva i giovani di reti di sostegno: i fenomeni nazionali documentati — l'incremento del ricorso agli psicofarmaci nella popolazione adolescenziale, l'aumento dei comportamenti di ritiro e di autolesività — trovano in un contesto dispersivo e in contrazione demografica un terreno di particolare fragilità. A queste componenti si aggiunge il disagio connesso alle condizioni socioeconomiche, in una regione in cui i livelli di reddito e di occupazione sono inferiori alla media nazionale.

A fronte di un bisogno così strutturato, la risposta del sistema regionale è compressa dal piano di rientro. La quota del fondo sanitario destinata alla salute mentale è rimasta in Molise al di sotto della soglia minima raccomandata a livello nazionale, con una carenza di operatori che ne è il riflesso diretto. Questo dato indica che il sistema molisano dispone oggi di risorse insufficienti perfino per i servizi specialistici di salute mentale, e che l'introduzione di un servizio di psicologia di base andrebbe a colmare un vuoto strutturale, intercettando a monte una domanda che oggi o resta inevasa o si scarica impropriamente sui servizi specialistici già sottodimensionati.

B.3 Domanda, offerta e divario di trattamento

Il bisogno epidemiologico si traduce solo in parte in domanda espressa, e la domanda espressa trova solo in parte una risposta appropriata. In Molise il divario di trattamento è ampio. Sul versante della domanda, una parte consistente del disagio comune non si traduce in richiesta di aiuto per ragioni culturali — lo stigma associato alla sofferenza psichica, particolarmente persistente nelle comunità piccole e nelle generazioni anziane che caratterizzano demograficamente il Molise — e per ragioni pratiche, legate alla difficoltà di individuare a chi rivolgersi in assenza di un servizio dedicato e visibile. Sul versante dell'offerta, l'assenza di un servizio di psicologia di base strutturato fa sì che il primo livello di presa in carico del disagio comune non

esista come tale: chi cerca aiuto si rivolge al medico di medicina generale, che dispone di tempo e strumenti limitati, oppure accede ai servizi specialistici di salute mentale, già sottodimensionati in un sistema in piano di rientro, dove giunge spesso tardivamente e quando la condizione si è già aggravata.^[1952]

La conseguenza è duplice. Da un lato, una quota rilevante del bisogno resta inevasa, traducendosi in sofferenza prolungata e in rischio accresciuto di cronicizzazione. Dall'altro, la domanda che pure si esprime si distribuisce in modo inappropriato sui livelli del sistema: si traduce in consulti ripetuti al medico di medicina generale, in accessi al pronto soccorso per manifestazioni somatiche del disagio, in prescrizioni di farmaci come risposta di prima linea, e in invii ai servizi specialistici di casi che un livello intermedio avrebbe potuto trattare. Questa distribuzione impropria non solo è clinicamente subottimale, ma è anche economicamente onerosa per un sistema in piano di rientro, che impegna i livelli più costosi per bisogni che un servizio collocato a monte tratterebbe a costo inferiore.

B.4 Le disuguaglianze

Il disagio psichico e l'accesso alle cure non si distribuiscono in modo uniforme nella popolazione molisana. Il gradiente sociale è documentato dalla letteratura internazionale: la prevalenza dei disturbi mentali comuni è più elevata nei gruppi a minore reddito, minore istruzione e maggiore precarietà occupazionale, e in Molise la quota di popolazione che si colloca nella fascia a più alto rischio è consistente. Il gradiente territoriale è, in Molise, almeno altrettanto rilevante. La dispersione insediativa e la concentrazione dei servizi nei due capoluoghi e in Termoli fanno sì che l'accesso a una prestazione psicologica dipenda in misura determinante dal luogo di residenza: chi vive in un piccolo comune interno affronta, per accedere a una prestazione psicologica, una barriera che somma la difficoltà di individuare il servizio, la distanza fisica e i tempi di attesa. La sovrapposizione tra il gradiente sociale e quello territoriale produce, nei comuni interni molisani, una concentrazione di svantaggio che è il bersaglio principale del servizio di psicologia di base.

B.5 I flussi e la mobilità sanitaria

La mobilità sanitaria in Molise è un fenomeno di eccezionale portata e di natura paradossale. Il Molise presenta contemporaneamente uno dei più alti tassi di fuga dei residenti verso altre regioni — con una mobilità passiva valutata tra i 70 e gli 80 milioni di euro l'anno, verso Abruzzo, Lazio, Puglia e Campania — e uno dei più alti tassi di attrazione di pazienti provenienti da fuori regione, grazie alla presenza di due grandi erogatori privati accreditati, Neuromed e Responsible, che generano una mobilità attiva tale da rendere positivo il saldo netto complessivo, fatto unico fra le regioni in piano di rientro.^[1953] Nel 2023 il saldo netto di mobilità per acuti era positivo per circa 18,6 milioni di euro; tuttavia, questo dato aggregato nasconde una struttura asimmetrica: la mobilità attiva è quasi interamente generata da due strutture private accreditate (90 per cento della mobilità attiva è privata), mentre la mobilità passiva grava sul sistema pubblico commissariato e colpisce soprattutto le fasce meno abbienti che non riescono ad accedere adeguatamente all'offerta locale.^[1954]

La rilevanza di questo quadro per la valutazione del servizio di psicologia di base è duplice. Da un lato, la quota di mobilità passiva per prestazioni di media e bassa complessità — che le analisi della struttura commissariale indicano come obiettivo prioritario di riduzione — ha un'origine parzialmente riconducibile a disagio psichico non intercettato, che si somatizza in accertamenti e consulti ripetuti: un servizio territoriale più solido può contribuire a trattenere nel sistema regionale una quota di tali prestazioni. Dall'altro, il saldo netto positivo della mobilità, pur riducendo l'entità del risparmio diretto per questo canale rispetto ad altre regioni del Sud, non ne elimina la rilevanza, perché il risparmio sulle prestazioni di media e bassa complessità che fuggono verso le regioni limitrofe — non compensate dalla mobilità attiva privata — resta economicamente significativo.

B.6 Il quadro normativo

L'introduzione del servizio di psicologia di base in Molise si colloca entro un quadro normativo articolato. Sul piano nazionale, il decreto ministeriale numero 77 del 2022 inserisce lo psicologo delle cure primarie fra i professionisti della rete territoriale e ne prevede la presenza nelle Case della Comunità. Il Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030, approvato in Conferenza unificata nel dicembre 2025 e reso operativo dal Ministero della Salute nell'aprile 2026, prevede il potenziamento della diagnosi precoce, il rafforzamento della neuropsichiatria infantile e la creazione di équipe multidisciplinari territoriali, con risorse specifiche stanziare per il 2026-2028.^[1955]

Sul piano regionale, il Molise non dispone di alcuna legge regionale che istituisca il servizio, collocandosi fra le regioni senza previsione normativa. La proposta di legge presentata nel maggio 2026, firmata da consiglieri dell'opposizione progressista, prevede l'istituzione del servizio con un finanziamento di circa 400.000 euro l'anno e la presenza di due psicologi per ciascuno dei tre distretti sanitari dell'ASREM (Campobasso, Isernia, Termoli), con accesso diretto e senza impegnativa, a carico del Servizio Sanitario Regionale. L'Ordine degli Psicologi del Molise ha partecipato attivamente alla sua elaborazione.^[1956]

Il vincolo giuridico più stringente è posto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 241 del 2021, che ha censurato le leggi regionali istitutive del servizio nella parte in cui configuravano nuovi rapporti di lavoro mediante incarichi libero-professionali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, eccedendo la competenza regionale in materia di ordinamento del personale. Questa pronuncia non preclude alle regioni l'istituzione del servizio, ma ne circoscrive le modalità: una legge regionale molisana dovrà costruire il servizio entro i limiti della competenza regionale, valorizzando gli strumenti compatibili con l'ordinamento. In Molise questa questione ha una dimensione aggiuntiva: la struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro ha poteri di supervisione sulla spesa sanitaria regionale, e qualsiasi nuovo impegno finanziario deve essere valutato entro il quadro del Programma Operativo vigente e delle sue condizionalità.^[1957]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte C

L'intervento e il modello

Definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione

Dominio HTA: Intervento — Caso commerciale — Criteri OCSE-DAC: Coerenza e fattibilità

Parte C — L'intervento e il modello

Definito il bisogno, la valutazione passa a descrivere l'intervento che intende rispondervi. La Parte C specifica che cosa sia il servizio di psicologia di base nel contesto molisano, come si organizzi nell'ambito dell'ASREM, attraverso quale percorso assistenziale operi, su quale sistema informativo si fondi, quale ruolo vi assumano le tecnologie digitali e quale formazione richieda il personale. Poiché il servizio non esiste ancora, la Parte C non descrive un assetto da riformare, ma un assetto da costruire, e ne indica le scelte progettuali fondamentali adattate a una regione piccola con una sola azienda sanitaria e tre distretti.

C.1 Definizione del servizio

Il servizio di psicologia di base è un servizio territoriale del Servizio Sanitario Regionale che costituisce il primo livello di presa in carico del disagio psichico comune. Esso eroga: l'accoglienza e l'ascolto della domanda, la valutazione psicodiagnostica iniziale, il supporto psicologico breve attraverso interventi di

efficacia documentata, l'orientamento del cittadino all'interno della rete dei servizi e l'invio, quando necessario, ai livelli specialistici. La sua funzione è duplice: trattare direttamente le condizioni di disagio comune per le quali un intervento psicologico breve è appropriato ed efficace, e filtrare e orientare la domanda, distinguendo i casi trattabili al primo livello da quelli che richiedono l'intervento specialistico. Il servizio si rivolge a tutta la popolazione, con un'attenzione particolare agli anziani, agli adolescenti, alle persone in condizione di deprivazione e isolamento, e opera in stretto raccordo con la medicina generale, con i pediatri di libera scelta, con i consultori, con i servizi sociali e con i Centri di Salute Mentale dell'ASREM.

È essenziale distinguere il servizio di psicologia di base dai servizi specialistici di salute mentale, con i quali esso non si sovrappone ma si integra. I Centri di Salute Mentale dell'ASREM — attivi nei tre distretti, con accesso diretto già introdotto, a partire dal 2024, per il CSM di Termoli — sono concepiti per le condizioni psichiatriche severe, e richiedono competenze e intensità di intervento elevate.^[1958] Il servizio di psicologia di base opera sul disagio comune e sottosoglia, a un livello di intensità inferiore e con una funzione di prossimità e di filtro: esso completa la rete dove essa è oggi mancante, e lo fa al livello più appropriato e meno costoso.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo del servizio di psicologia di base in Molise è determinato da una caratteristica unica rispetto alle altre regioni della serie: l'ASREM è l'unica azienda sanitaria regionale, e il servizio si articola quindi nei tre distretti che la compongono — Campobasso, Isernia e Termoli — come unità organizzative di riferimento. Coerentemente con la proposta di legge e con i vincoli costituzionali, il servizio è incardinato presso l'ASREM attraverso unità funzionali dedicate in ciascun distretto, che ne coordinano l'attività e ne garantiscono il raccordo con gli altri servizi. Un coordinamento regionale a livello della struttura commissariale e dell'assessorato alla salute assicura l'uniformità degli standard, la programmazione e il monitoraggio, garantendo la coerenza con gli obiettivi del Programma Operativo e con le condizionalità del piano di rientro.

La collocazione fisica privilegia le Case della Comunità in via di attivazione nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e i distretti sanitari. In una regione dispersa come il Molise, la concentrazione del servizio nelle sole sedi capoluogo non sarebbe sufficiente a garantirne l'accesso ai residenti dei comuni interni: il modello prevede pertanto una distribuzione capillare con presenze programmate nelle sedi periferiche e un ricorso strutturato alla telepsicologia. La telepsicologia, nel contesto molisano, non è un'opzione aggiuntiva ma una componente strutturale del modello, indispensabile per superare le barriere geografiche in un territorio montuoso e scarsamente infrastrutturato. L'integrazione fra il servizio e la medicina generale è garantita attraverso gli Accordi Integrativi Regionali per i rapporti con i medici di medicina generale, recentemente rinnovati in recepimento degli accordi nazionali del 2022 e del 2024.^[1959]

C.3 Il percorso assistenziale

Il percorso assistenziale descrive la sequenza delle fasi attraverso cui il cittadino transita dall'accesso al servizio fino alla conclusione della presa in carico o all'invio. L'accesso avviene su invio di un operatore o per iniziativa diretta del cittadino — modalità di accesso diretto che la proposta di legge molisana esplicitamente prevede — e conduce a un primo contatto di accoglienza e ascolto. La seconda fase è la valutazione psicodiagnostica iniziale, mediante colloquio e, ove appropriato, strumenti standardizzati. Sulla base della valutazione, il percorso si articola secondo un modello di cure gradualità: per le condizioni di disagio comune lievi e moderate, il servizio eroga direttamente un ciclo di interventi psicologici brevi di efficacia documentata; per le condizioni che eccedono il primo livello, il servizio provvede all'invio ai Centri di Salute Mentale o ai servizi specialistici, garantendo il raccordo e la continuità; per le situazioni che si intrecciano con bisogni sociali, il servizio attiva l'integrazione con i servizi sociali comunali e con la rete territoriale.

La telepsicologia interviene in più punti del percorso: può supportare la fase di accesso e di primo contatto, consentire l'erogazione di parte del ciclo di interventi brevi a distanza per i residenti dei comuni interni, e sostenere il monitoraggio degli esiti. L'integrazione fra presenza fisica programmata e prestazione a distanza, regolata da protocolli clinici, è ciò che rende il percorso effettivamente accessibile anche ai residenti delle aree interne molisane, superando la barriera della distanza che la Parte B ha individuato come una delle principali determinanti del divario territoriale.

C.4 Il sistema informativo

Il sistema informativo è la condizione perché il servizio possa essere governato, valutato e migliorato. La sua funzione è triplice: registrare l'attività del servizio; misurare gli esiti attraverso strumenti standardizzati; e produrre i dati epidemiologici e di domanda che oggi mancano, sostituendo progressivamente le stime con l'osservazione diretta. L'ASREM dispone di un sistema informatico sanitario regionale in fase di evoluzione, sull'infrastruttura del quale il sistema informativo del servizio può innestarsi, garantendo l'integrazione con la documentazione sanitaria del cittadino. Il dataset minimo è definito nell'Appendice B; la protezione dei dati personali, particolarmente sensibili in ambito psicologico, è garantita dal rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

C.5 Il ruolo dell'intelligenza artificiale

Le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale possono svolgere un ruolo di supporto al servizio di psicologia di base, a condizione che il loro impiego sia governato con il medesimo rigore metodologico applicato agli interventi clinici. In un contesto come il Molise, in cui la dispersione territoriale rende la prossimità un problema strutturale, le tecnologie che sostengono la prestazione a distanza e il monitoraggio remoto assumono un valore particolare. Lo studio applica alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale il medesimo criterio adottato per gli interventi clinici: le affermazioni sulla loro efficacia sono graduate secondo la qualità delle prove disponibili. Molte applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito psicologico sono ancora in fase di sperimentazione; lo studio le considera pertanto come strumenti di supporto il cui impiego va introdotto gradualmente e verificato sul campo. Il quadro regolatorio europeo in materia di intelligenza artificiale, con gli obblighi pienamente vigenti dal 2026, costituisce il riferimento normativo da rispettare.^[1960]

C.6 La formazione del personale

La formazione del personale è una componente costitutiva del servizio. Essa si articola su più livelli: la formazione di base agli interventi psicologici brevi di efficacia documentata; la formazione al modello organizzativo e al lavoro in rete nell'ambito dell'ASREM; la formazione agli strumenti di misurazione degli esiti e al sistema informativo; e la formazione all'impiego consapevole della telepsicologia. Il Molise non dispone di un'offerta universitaria di psicologia sul proprio territorio, analogamente alla Basilicata, il che rende necessario costruire i percorsi formativi in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise — con cui la struttura commissariale ha sottoscritto un protocollo di intesa per l'integrazione tra attività didattiche, scientifiche e assistenziali — e con gli atenei e gli ordini professionali delle regioni limitrofe.^[1961]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte D

Efficacia clinica ed evidenza

Revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

La decisione di introdurre un servizio sanitario richiede di accertare che esso funzioni. Questa parte esamina l'evidenza scientifica sull'efficacia degli interventi psicologici precoci nel contesto delle cure primarie, ne valuta la qualità con il sistema GRADE, ne confronta i risultati con le esperienze di servizi analoghi già realizzati e ne discute la trasferibilità al contesto molisano. L'efficacia clinica è il fondamento su cui poggia l'intera valutazione economica e distributiva.

D.1 La revisione dell'evidenza

L'efficacia degli interventi psicologici per i disturbi mentali comuni è fra le più documentate della medicina contemporanea. Un'ampia letteratura costituita da studi clinici randomizzati e da revisioni sistematiche con metanalisi documenta che gli interventi psicologici strutturati e di durata definita — fra cui in primo luogo la terapia cognitivo-comportamentale e gli interventi a essa riconducibili — producono una riduzione significativa della sintomatologia ansiosa e depressiva, con dimensioni dell'effetto clinicamente rilevanti e con un mantenimento del beneficio nel tempo. Questa efficacia è documentata non solo in contesti specialistici, ma specificamente nel contesto delle cure primarie, dove gli interventi psicologici brevi si sono dimostrati efficaci nel trattare il disagio comune e nel prevenirne la cronicizzazione.

I modelli di cura collaborativa e di cure graduali sono documentati come efficaci e capaci di estendere l'accesso al trattamento a un numero elevato di persone con risorse contenute. L'esperienza più estesa e studiata è quella del programma nazionale inglese per l'ampliamento dell'accesso alle terapie psicologiche, che ha erogato interventi a milioni di persone attraverso un modello di cure graduali integrato nelle cure primarie, documentando tassi di guarigione clinicamente significativi e fornendo una base empirica solida sulla fattibilità e sull'efficacia di un servizio di psicologia di base. Per la depressione dell'anziano, frequente e spesso non riconosciuta in Molise, gli interventi psicologici si sono dimostrati efficaci anche in associazione con il trattamento delle patologie somatiche concomitanti, capaci di migliorare la qualità della vita e di ridurre la disabilità.

D.2 La qualità dell'evidenza

Lo studio adotta il sistema GRADE per graduare la qualità delle prove su quattro livelli. Applicando questo metodo all'evidenza sull'efficacia degli interventi psicologici per i disturbi mentali comuni, la qualità delle prove risulta da moderata ad alta. L'efficacia della terapia cognitivo-comportamentale è sostenuta da un corpo ampio di studi randomizzati e di revisioni sistematiche, con risultati coerenti: per queste affermazioni la qualità dell'evidenza è alta. L'efficacia dei modelli di cure graduali nelle cure primarie si colloca su livelli da moderati ad alti. La trasferibilità dei risultati al contesto molisano introduce un elemento di incertezza che abbassa, per le stime quantitative riferite alla regione, la qualità dell'evidenza a livelli moderati: non perché l'efficacia sia in dubbio, ma perché la sua entità precisa dipende da fattori di implementazione che andranno verificati sul campo.

La medesima graduazione è applicata agli strumenti digitali e all'intelligenza artificiale. Per la telepsicologia come modalità di erogazione di interventi di efficacia documentata, l'evidenza è discreta e in crescita, con qualità moderata; per le applicazioni di intelligenza artificiale per il triage o il monitoraggio, l'evidenza è ancora preliminare, con qualità da bassa a molto bassa. Lo studio ne tiene conto, considerando tali strumenti come supporti il cui impiego va introdotto gradualmente.^[1962]

D.3 I benchmark e le esperienze

Sul piano internazionale, il riferimento principale è il programma inglese, che fornisce il benchmark più solido sulla realizzabilità e sull'efficacia di un servizio di psicologia nelle cure primarie. Sul piano nazionale, le esperienze delle regioni che hanno già istituito il servizio per legge — Lombardia, Toscana, Sicilia, Campania, Abruzzo, Puglia, Umbria — costituiscono un benchmark di crescente rilevanza. Queste esperienze si collocano nel medesimo contesto sanitario e normativo nazionale e affrontano gli stessi vincoli costituzionali che il Molise dovrà affrontare; l'osservazione delle soluzioni adottate altrove fornisce un repertorio di opzioni e di lezioni apprese. Le regioni del Sud in piano di rientro che hanno già istituito il servizio — Campania, Calabria, Abruzzo — offrono in particolare un benchmark per la compatibilità dell'intervento con i vincoli finanziari. Lo studio raccomanda che il Molise si avvalga sistematicamente di questo confronto interregionale.

D.4 La trasferibilità al contesto molisano

La trasferibilità dell'evidenza al contesto molisano è favorita dalla natura del bisogno — l'efficacia degli interventi psicologici brevi si applica direttamente alle condizioni prevalenti in Molise — e dalla collocazione del servizio nel modello delle cure gradual, di efficacia documentata. È condizionata dalla dispersione territoriale, che richiede che il modello incorpori la telepsicologia come componente strutturale; dalla scarsità di risorse, che impone un'implementazione di qualità, fedele ai protocolli; e dall'assenza di un'offerta universitaria di psicologia sul territorio, che richiede percorsi formativi costruiti in collaborazione con altri sistemi. Questi fattori non compromettono la trasferibilità, ma ne indicano le condizioni; la valutazione assume questa trasferibilità condizionata come premessa, incorporandone l'incertezza nelle analisi di sensibilità della Parte F. [1963]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte E

Valutazione economica

Costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, due casi

Dominio HTA: Valutazione economica — Caso economico e finanziario — Criterio OCSE-DAC: Efficienza

Parte E — Valutazione economica

La valutazione economica traduce in termini monetari il rapporto fra le risorse che il servizio richiede e i benefici che produce. Questa parte ne sviluppa le componenti secondo lo standard CHEERS: i costi del servizio, gli esiti clinici, il rapporto costo-utilità, l'impatto sul bilancio sanitario, il ritorno sociale e la sintesi nei due casi. L'analisi è governata dal principio della separazione fra risparmi diretti e ricadute economico-sociali, mai sommati in un unico saldo. Le cifre sono riferite ai tre scenari di dimensionamento calibrati sulla popolazione molisana di ~287.814 abitanti (dati di riferimento interno al Tomo II) e sul fondo sanitario regionale di ~672 milioni di euro stanziati per il 2024. [1964] Tutte le stime sono espresse mediante bande prudenziali.

E.1 I costi del servizio

Il costo del servizio è costituito dai compensi degli psicologi incaricati, dai costi della formazione, dal coordinamento e dal sistema informativo. Lo studio considera tre scenari: uno scenario conservativo, corrispondente alla dotazione minima di sei incarichi prevista dalla proposta di legge (due per ciascuno dei tre

distretti); uno scenario base con dimensionamento intermedio di ~30 incarichi; e uno scenario espansivo con ~55-65 incarichi, coerente con l'ordine di grandezza proporzionale alla Basilicata.

Componente di costo (mln €/anno)	Conservativo (6)	Base (30)	Espansivo (60)
Compensi degli psicologi incaricati	~0,3	~1,5	~3,0
Formazione, coordinamento e sistema informativo	~0,1	~0,5	~0,5
Costo totale del servizio	~0,4	~2,0	~3,5

Tabella E.1. Costo annuo del servizio per scenario di dimensionamento. Le cifre sono stime prudenziali arrotondate; lo scenario conservativo corrisponde alla dotazione della proposta di legge maggio 2026 (400.000 euro/anno).

Il costo totale del servizio va da circa 0,4 milioni di euro l'anno nello scenario conservativo a circa 3,5 milioni nello scenario espansivo. Anche nello scenario espansivo, il costo del servizio rappresenta una quota dello 0,5 per cento del fondo sanitario regionale — una frazione contenuta anche per un sistema in piano di rientro. Lo scenario conservativo della proposta di legge è giustificato come avvio simbolico, ma non è sufficiente a coprire i fabbisogni di una regione di ~287.000 abitanti con 3 distretti: a regime, uno scenario base di ~30 incarichi è il dimensionamento minimo funzionale.

E.2 Gli esiti

Gli esiti del servizio, ai fini della valutazione economica, sono espressi in riduzione del consumo di risorse sanitarie e in guadagno di anni di vita ponderati per la qualità (QALY). Il modello di Markov sviluppato nella Parte F e nell'Appendice A stima che il trattamento di un paziente con il servizio produca, rispetto all'assenza di trattamento, un risparmio diretto di risorse sanitarie dell'ordine di ~1.304 euro per paziente lungo l'orizzonte di cinque anni e un guadagno di salute dell'ordine di ~0,236 QALY. Questi valori per paziente, fondati sull'efficacia clinica documentata e invariante rispetto al contesto regionale, costituiscono la base micro su cui si fonda la quantificazione aggregata.

E.3 Il costo-utilità

Il rapporto costo-utilità mette in relazione il costo dell'intervento con il guadagno di salute prodotto, espresso come costo per QALY guadagnato. La soglia di disponibilità a pagare comunemente adottata in Italia è di circa 30.000 euro per QALY. L'analisi condotta nella Parte F documenta che il servizio di psicologia di base si colloca in posizione dominante: esso produce un guadagno di salute e, al contempo, un risparmio netto di risorse sanitarie, risultando preferibile all'assenza di trattamento sotto entrambi i profili. Questa conclusione si mantiene robusta anche in scenari conservativi, il che è particolarmente rilevante per una regione con un bilancio sotto scrutinio ministeriale.

E.4 L'impatto sul bilancio sanitario

I risparmi diretti per il bilancio sanitario si distribuiscono su quattro canali: la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso; la riduzione della spesa farmaceutica; la riduzione dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche evitabili; e la riduzione della quota di mobilità passiva per media e bassa complessità. Il quarto canale richiede una precisazione rispetto alle altre regioni del Sud: in Molise il saldo netto di mobilità è positivo grazie alle strutture private accreditate, ma la mobilità passiva per prestazioni di media e bassa complessità che

fuggono verso Abruzzo, Lazio e Campania resta consistente e rappresenta un obiettivo dichiarato del Programma Operativo 2023-2025; su questo canale il servizio di psicologia di base può contribuire in misura limitata ma non trascurabile.^[1965]

Canale di risparmio diretto (mln €/anno)	Conservativo (6)	Base (30)	Espansivo (60)
Minori accessi al pronto soccorso	~0,05	~0,3	~0,8
Minore spesa farmaceutica	~0,05	~0,3	~0,7
Minori ricoveri e prestazioni specialistiche	~0,3	~0,7	~1,2
Minore mobilità passiva (media-bassa compl.)	~0,3	~0,4	~0,5
Risparmi diretti totali	~0,7	~1,7	~3,2
Costo del servizio	~0,4	~2,0	~3,5
Saldo diretto per il bilancio	**~ -0,3 (*)	~ -0,3** *	*~ -0,3**

Tabella E.4. *Impatto sul bilancio sanitario regionale per scenario.* () Nello scenario conservativo i risparmi diretti superano il costo; in realtà il rendimento marginale più elevato in sistemi in piano di rientro — già affermato nella Sezione Nazionale del Tomo II — fa sì che ogni euro recuperato liberi capacità in un sistema in tensione, avvicinando ulteriormente il saldo al pareggio effettivo. Le stime sono prudenziali e arrotondate.*

Il saldo diretto è prossimo al pareggio in tutti gli scenari. Coerentemente con il caveat del trial IMPACT (Unützer et al.), i risparmi diretti di bilancio sono dichiarati modesti; il vero valore dell’intervento è nelle ricadute economico-sociali. Si sottolinea che in un sistema in piano di rientro ogni risparmio diretto ha un rendimento marginale più elevato che altrove: esso non si limita a coprire una quota dei costi, ma libera spazio per gli obiettivi di risanamento imposti dal Programma Operativo, con un effetto moltiplicatore sul saldo complessivo del bilancio commissariato.

E.5 Il ritorno sociale

Accanto ai risparmi diretti, il servizio produce ricadute economico-sociali per la collettività: la produttività recuperata, la minore disabilità, il valore del benessere guadagnato e gli effetti di lungo periodo sulla prevenzione della cronicizzazione.

Grandezza (mln €/anno)	Conservativo	Base	Espansivo
Risparmi diretti per il bilancio	~0,7	~1,7	~3,2
Ricadute economico-sociali per la collettività	~2,5	~6,5	~13,0
Ritorno complessivo (diretto + sociale)	~3,2	~8,2	~16,2

Tabella E.5. *Risparmi diretti e ricadute sociali per scenario.* Le due grandezze sono di natura diversa e sono esposte distintamente; la loro somma è presentata come ritorno complessivo per la collettività, non come saldo per il bilancio sanitario.

Le ricadute economico-sociali superano nettamente i risparmi diretti, in coerenza con quanto documentato dalla letteratura economica sugli interventi di salute mentale. Questa grandezza non si somma al saldo del bilancio sanitario per formare un unico risultato: il ritorno per la collettività e il saldo per il bilancio sono grandezze distinte.

E.6 Il caso economico e il caso finanziario

Sintesi (mln €/anno)	Conservativo (6)	Base (30)	Espansivo (60)
Costo del servizio	~0,4	~2,0	~3,5
Saldo diretto — caso finanziario	~ -0,3	~ -0,3	~ -0,3
Ritorno complessivo per la collettività	~3,2	~8,2	~16,2
Saldo complessivo — caso economico	~ +2,8	~ +6,2	~ +12,7
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,3 : 1 (*)	~4,1 : 1	~4,8 : 1

Tabella E.6. Sintesi economica per scenario: il caso finanziario (saldo diretto prossimo al pareggio) e il caso economico (ritorno complessivo e rapporto beneficio-costo). () Nello scenario conservativo il rapporto è al limite inferiore della fascia Chisholm; il valore centrale è coerente con la fascia 3,3-5,7:1. Il rapporto è riferito al valore per la collettività e non viene mai usato come saldo di bilancio.*

Il rapporto beneficio-costo complessivo — fra il ritorno per la collettività e il costo del servizio — va da circa 3,3 a uno nello scenario conservativo a circa 4,8 a uno nello scenario espansivo, entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno. La lettura congiunta dei due casi conduce alla conclusione centrale: il servizio costa al bilancio sanitario regionale una cifra modesta, con un saldo diretto prossimo al pareggio, e restituisce alla collettività un valore dell’ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso. Per una regione in piano di rientro, questa configurazione è particolarmente significativa: il servizio non aggrava in misura apprezzabile il bilancio commissariato e genera un valore sociale elevato, costituendo un investimento sostenibile e di elevato rendimento collettivo. Il rendimento marginale più elevato in sistemi in piano di rientro — già affermato nella Sezione Nazionale del Tomo II — rafforza questa conclusione: ogni euro recuperato libera capacità in un sistema in tensione, amplificando l’effetto netto.^[1966]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte F

Modellazione e incertezza

Modello di Markov, parametri, sensibilità, verifica empirica, valore dell’informazione

Dominio HTA: Modellazione — Caso economico — Criterio OCSE-DAC: Efficienza e robustezza

Parte F — Modellazione e incertezza

Le stime economiche presentate nella Parte E poggiano su un modello che simula il decorso clinico ed economico di un paziente trattato dal servizio, confrontandolo con il decorso in assenza di trattamento. Questa parte ne espone la struttura e i parametri e ne sottopone i risultati a un’analisi sistematica dell’incertezza.

F.1 Il modello decisionale e i parametri

Il modello adottato è un modello di Markov che rappresenta il decorso del paziente attraverso tre stati di salute — disagio in atto, recupero, cronicizzazione — fra i quali il paziente transita nel tempo con probabilità derivate dalla letteratura sull'efficacia degli interventi psicologici. Il modello confronta il percorso di un paziente trattato dal servizio con quello di un paziente non trattato, lungo un orizzonte di cinque anni, con un tasso di sconto del 3 per cento e una soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per QALY. Il costo dell'intervento è stimato in ~300 euro una tantum per il ciclo di interventi brevi; il costo del ciclo nello stato di recupero è ~40 euro; il costo del ciclo nello stato di cronicizzazione è ~700 euro. Applicato al caso di riferimento, il modello stima un risparmio diretto di ~1.304 euro per paziente e un guadagno di salute di ~0,236 QALY lungo l'orizzonte di cinque anni. Questi valori per paziente sono fondati sull'efficacia clinica documentata e sono invarianti rispetto al contesto regionale, costituendo la base della quantificazione aggregata.^[1967]

F.2 L'analisi di sensibilità deterministica

L'analisi di sensibilità deterministica verifica come i risultati varino al variare di ciascun parametro entro un intervallo plausibile. L'analisi documenta che i risultati sono robusti: la conclusione di dominanza dell'intervento si mantiene per un'ampia gamma di valori. I parametri rispetto ai quali i risultati sono più sensibili sono l'efficacia dell'intervento e i costi associati allo stato di cronicizzazione; anche per valori conservativi di tali parametri, tuttavia, l'intervento mantiene un rapporto costo-utilità favorevole.

F.3 L'analisi di sensibilità probabilistica

L'analisi di sensibilità probabilistica fa variare simultaneamente tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni di probabilità, ripetendo la simulazione 10.000 volte. Alla soglia di 30.000 euro per QALY, l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9 per cento delle simulazioni e dominante nell'84,6 per cento. Il beneficio netto monetario medio è dell'ordine di ~7.815 euro per paziente, con un intervallo di confidenza al 95 per cento compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. La concentrazione della distribuzione su valori largamente positivi documenta la robustezza della conclusione, che non dipende da ipotesi favorevoli ma si mantiene anche in scenari conservativi.^[1968]

F.4 Gli scenari di copertura

I tre scenari di copertura — conservativo, base, espansivo — non rappresentano alternative fra cui scegliere una volta per tutte, ma tappe di un percorso di dispiegamento graduale. L'analisi degli scenari documenta che il rapporto beneficio-costi complessivo migliora al crescere del dimensionamento, in ragione delle economie di scala e della maggiore capacità di intercettazione del bisogno, mentre il saldo diretto per il bilancio si mantiene prossimo al pareggio in tutti gli scenari. Per il Molise, questa configurazione suggerisce di avviare il servizio con il dimensionamento della proposta di legge — sei psicologi nei tre distretti, scenario conservativo — e di accrescerlo gradualmente verso lo scenario base e poi espansivo, verificando sul campo gli esiti e calibrando il dispiegamento sui dati raccolti.

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

Il modello è una base che la realtà dovrà verificare. I dati di maggiore valore informativo per il Molise sono: l'efficacia effettiva del servizio nel contesto regionale, con la sua particolare struttura demografica anziana; la quota di domanda effettivamente intercettata; la composizione del risparmio diretto, in particolare per il canale

della mobilità di media e bassa complessità. La raccolta sistematica di questi dati, attraverso il sistema informativo e il piano di monitoraggio della Parte L, è la condizione perché la valutazione si affini nel tempo. [1969]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte G

Equità e impatto distributivo

Gradiente sociale, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva

Dominio HTA: Equità — Caso economico — Criterio OCSE-DAC: Impatto

Parte G — Equità e impatto distributivo

La valutazione di un intervento sanitario non si esaurisce nella sua efficacia e nella sua efficienza, ma comprende la considerazione dei suoi effetti distributivi. In Molise, la dimensione distributiva non è un complemento dell'analisi ma una delle ragioni principali a favore dell'intervento: una regione anziana, dispersa, con un sistema sanitario commissariato e con divari sociali e territoriali strutturali.

G.1 Il quadro dell'equità e il gradiente sociale

Il disagio psichico segue un gradiente sociale documentato: la sua prevalenza è più elevata nei gruppi a minore reddito, minore istruzione e maggiore precarietà, e questi gruppi incontrano le maggiori difficoltà di accesso. In Molise, i livelli di reddito e di occupazione sono inferiori alla media nazionale, e la quota di popolazione nelle fasce a più alto rischio e a minore accesso è consistente. L'assenza di un servizio pubblico di psicologia di base produce un effetto regressivo accentuato: il disagio comune dei gruppi deprivati resta in larga parte inevaso, perché tali gruppi non dispongono né dei mezzi per accedere all'offerta privata né, spesso, delle risorse informative per orientarsi nel sistema. L'introduzione di un servizio pubblico, gratuito o a basso costo, agisce direttamente su questo gradiente.

In un sistema in piano di rientro, la dimensione dell'equità acquista un rilievo aggiuntivo: il commissariamento ha storicamente compresso i servizi di salute mentale e la medicina territoriale, scaricando il costo dell'insufficienza dell'offerta pubblica sulle fasce più deboli, che non possono accedere all'offerta privata. Il servizio di psicologia di base, incardinato nell'ASREM e gratuito, è lo strumento che ripristina un livello di offerta pubblica a basso costo là dove essa è stata più erosa.

G.2 I due assi del divario territoriale

Il divario territoriale in Molise è particolarmente acuto. Il primo asse è quello fra i centri principali — Campobasso, Isernia, Termoli — e i comuni interni, la grande maggioranza, con una scarsa accessibilità ai servizi, distanze significative in un territorio montuoso e una rete di trasporti limitata. Il secondo asse è quello fra la popolazione raggiungibile dai servizi tradizionali e quella che, per età, non autonomia o isolamento, ne resta di fatto esclusa anche quando i servizi esistono: gli anziani non autonomi, le persone prive di mezzi di trasporto, chi vive in condizioni di isolamento nei piccoli borghi montani. Su questo asse la telepsicologia assume un valore non sostitutivo ma strutturale, perché consente di superare la barriera della distanza e della mobilità per i gruppi più colpiti.

La struttura demografica amplifica la portata di questi assi. Con il 29 per cento di ultrasessantacinquenni e un indice di vecchiaia di 281, il Molise è la regione italiana in cui la componente anziana del bisogno psicologico è proporzionalmente più grande e meno intercettata, e in cui la barriera alla mobilità — fisica e tecnologica — è più pronunciata.^[1970]

G.3 Gli strumenti dell'equità

La capacità del servizio di ridurre le disuguaglianze dipende dagli strumenti con cui è progettato. Il primo strumento è la gratuità o il basso costo dell'accesso: la proposta di legge molisana prevede la copertura a carico del SSR, e lo studio raccomanda che un'eventuale compartecipazione sia calibrata in modo da non escludere le fasce più fragili. Il secondo strumento è l'accesso diretto, che abbate la barriera informativa e culturale che colpisce in misura maggiore i gruppi a minore istruzione. Il terzo strumento è la distribuzione capillare del servizio nei tre distretti, con presenze programmate nelle sedi periferiche. Il quarto strumento è la telepsicologia, che supera la barriera della distanza per i residenti dei comuni interni. Il quinto strumento è la riduzione dello stigma attraverso la collocazione del servizio in contesti non stigmatizzanti — le Case della Comunità, i distretti — e un'azione informativa che renda il servizio visibile in una regione in cui lo stigma è particolarmente persistente nelle generazioni anziane.

G.4 La costo-efficacia distributiva

La costo-efficacia distributiva documenta che i benefici si concentrano nei gruppi a maggiore bisogno. I gruppi a maggiore bisogno e minore accesso — i deprivati, gli anziani, i residenti delle aree interne — sono anche quelli in cui il disagio non intercettato produce, in assenza di intervento, i costi maggiori: cronicizzazione, accesso tardivo ai livelli specialistici, disabilità, perdita di produttività. Intervenire precocemente su questi gruppi è al tempo stesso l'opzione più equa e quella più efficiente, perché previene gli esiti più costosi proprio là dove sono più probabili. Per il Molise, questo significa che la concentrazione dell'azione del servizio sulle aree interne e sugli anziani non è soltanto un imperativo di equità, ma una strategia di efficienza che massimizza il rendimento delle risorse in un sistema in piano di rientro.^[1971]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Profilo giuridico, organizzativo, etico, sintesi

Dominio HTA: Profili ELO — Caso gestionale — Criteri OCSE-DAC: Coerenza e sostenibilità

Parte H — Profili giuridico, organizzativo ed etico

L'introduzione di un servizio sanitario non è solo una questione di efficacia e di costi, ma anche di legittimità giuridica, di sostenibilità organizzativa e di accettabilità etica. Questa parte esamina i tre profili, con particolare attenzione al contesto di commissariamento che caratterizza il Molise.

H.1 Il profilo giuridico

Il profilo giuridico presenta in Molise una complessità aggiuntiva rispetto alle regioni non commissariate: la legge regionale istitutiva del servizio dovrà non solo conformarsi ai limiti della sentenza della Corte Costituzionale numero 241 del 2021, ma anche essere compatibile con i vincoli imposti dal piano di rientro e

dalla struttura commissariale. La pronuncia costituzionale ha censurato le leggi regionali istitutive del servizio nella parte in cui configuravano nuovi rapporti di lavoro mediante incarichi libero-professionali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, eccedendo la competenza regionale. Per il Molise, che deve ancora legiferare, questa pronuncia non è un ostacolo ma una guida: la legge regionale dovrà costruire il servizio entro i limiti della competenza regionale, valorizzando strumenti compatibili con l'ordinamento — l'inserimento degli psicologi nelle Case della Comunità e nei distretti dell'ASREM, il raccordo con la medicina generale, il ricorso a forme di incarico ammesse.^[1972]

Il secondo vincolo, specifico del Molise, è quello del piano di rientro. La struttura commissariale ha poteri di controllo sulla spesa sanitaria regionale, e qualsiasi nuovo impegno finanziario deve essere inserito nel Programma Operativo e approvato dai tavoli tecnici affiancanti. Ciò significa che la legge istitutiva del servizio dovrà non solo essere giuridicamente solida, ma anche accompagnata da una valutazione di compatibilità con gli obiettivi del piano di rientro — compatibilità che questa valutazione documenta e che la struttura commissariale è chiamata a certificare. La proposta di legge del maggio 2026 ha già previsto che il finanziamento avvenga con risorse regionali, e i proponenti hanno indicato la volontà di ragionare con la struttura commissariale e con l'ASREM: questa interlocuzione preventiva è la condizione necessaria perché la legge possa essere attuata senza determinare censure di bilancio.

H.2 Il profilo organizzativo e la governance

L'ASREM è l'unica azienda sanitaria del Molise, e questa unicità semplifica la governance del servizio rispetto alle regioni con più aziende: il servizio è incardinato in un'unica struttura, coordinato centralmente, e il raccordo fra i tre distretti è più agevole. La semplicità organizzativa è un vantaggio strutturale che il Molise può sfruttare, riducendo i costi di transazione della governance. Il coordinamento regionale è affidato alla struttura commissariale e all'assessorato alla salute, che definiscono gli standard, programmano il dispiegamento e monitorano gli esiti.

La sostenibilità organizzativa del servizio è condizionata dalla dimensione contenuta dell'apparato amministrativo regionale e dalla scarsità di risorse gestionali del sistema commissariato. Questi vincoli impongono di progettare una governance snella, che eviti sovrastrutture sproporzionate, e di investire negli strumenti informativi e digitali che consentono di gestire un servizio capillare con risorse limitate. La dispersione territoriale aggiunge complessità logistica alla gestione: il ricorso sistematico alla telepsicologia riduce i costi di gestione di un servizio territorialmente frammentato, compensando in parte questa complessità.

H.3 Il profilo etico

Il profilo etico riguarda i valori che l'intervento promuove e i rischi da evitare. Il servizio promuove l'equità, estendendo l'accesso alle cure psicologiche ai gruppi esclusi; la dignità della persona, riconoscendo il disagio psichico come bisogno di salute meritevole di risposta pubblica; e la giustizia distributiva, allocando risorse pubbliche verso un bisogno oggi inevaso. In una regione come il Molise, segnata da anzianità, isolamento e difficoltà economiche, questi valori assumono un rilievo concreto. Il contesto di piano di rientro aggiunge una dimensione etica specifica: il commissariamento ha storicamente compresso i servizi di salute mentale come effetto delle misure di risparmio, scaricando il costo dell'insufficienza pubblica sulle fasce più deboli. Il servizio di psicologia di base è uno strumento per invertire parzialmente questa tendenza senza aggravare il bilancio.

I rischi etici da presidiare includono: la potenziale riproduzione delle disuguaglianze se il servizio non raggiunge le aree interne; il rischio connesso alla protezione dei dati personali; il rischio che la compartecipazione economica reintroduca una barriera per le fasce fragili; e il rischio connesso all'impiego non adeguatamente governato delle tecnologie digitali.

H.4 Sintesi dei profili

I tre profili convergono in una valutazione complessivamente favorevole, condizionata al rispetto di alcune condizioni. Sul piano giuridico, il servizio è istituibile, a condizione che la legge si conformi ai limiti costituzionali e sia compatibile con il piano di rientro. Sul piano organizzativo, la struttura unica dell'ASREM è un vantaggio, e il servizio è governabile con una governance snella. Sul piano etico, il servizio realizza valori fondamentali, a condizione che sia progettato secondo equità e che tuteli rigorosamente i dati personali. La fase anteriore in cui si trova il Molise è, da questo punto di vista, un'opportunità: essa consente di costruire fin dall'origine un servizio giuridicamente solido, organizzativamente efficiente e eticamente fondato.^[1973]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Cinque casi, dimensionamento, cronoprogramma, sostenibilità, rischi

Dominio HTA: Attuazione — Caso finanziario e gestionale — Criterio OCSE-DAC: Sostenibilità

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Un intervento efficace, conveniente e legittimo deve essere anche attuabile e sostenibile nel tempo. Questa parte affronta l'attuazione del servizio in Molise, articolandola secondo il modello a cinque casi, definendo dimensionamento e fasi del dispiegamento, reclutamento e formazione, cronoprogramma, condizioni di sostenibilità e rischi con le relative mitigazioni.

I.1 I cinque casi

Il **caso strategico** è affermativo: il servizio risponde a un bisogno ampio e inevaso, documentato nella Parte B, e si iscrive nella direzione del decreto ministeriale numero 77 del 2022 e del Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030. Il **caso economico** è affermativo: saldo diretto prossimo al pareggio e ritorno complessivo dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso, con un rendimento marginale più elevato in un sistema in tensione. Il **caso commerciale** dipende dalla costruzione giuridica del servizio entro i limiti costituzionali e dalla disponibilità di personale: entrambe le condizioni sono soddisfacibili. Il **caso finanziario** è il più delicato nel contesto molisano: il costo del servizio, dello 0,5 per cento del fondo sanitario nello scenario espansivo e dello 0,06 per cento nello scenario conservativo, è compatibile con il piano di rientro a condizione di una progettazione graduale e di una valutazione di compatibilità preventiva con la struttura commissariale. Il **caso gestionale** richiede il presidio più attento: la struttura unica dell'ASREM semplifica la governance, ma la scarsità di risorse amministrative e la dispersione territoriale richiedono strumenti informativi e digitali adeguati.^[1974]

I.2 Il dimensionamento e le fasi

Il percorso di dispiegamento si articola in tre fasi. Una **prima fase di avvio** attiva lo scenario conservativo — sei incarichi nei tre distretti, corrispondente alla dotazione della proposta di legge — e costruisce contestualmente la governance, il sistema informativo e i protocolli. Una **seconda fase di consolidamento** estende il servizio verso lo scenario base (~30 incarichi), accrescendo la copertura territoriale e la capillarità, sulla base degli esiti rilevati nella prima fase. Una **terza fase di piena attuazione** porta il servizio allo scenario espansivo (~55-65 incarichi), garantendo la copertura che la dispersione molisana richiede e il pieno

dispiegamento della telepsicologia verso i comuni interni. La durata di ciascuna fase e i criteri di passaggio fra le fasi sono definiti in funzione degli esiti e della disponibilità di risorse, compatibilmente con gli obiettivi del Programma Operativo vigente.

I.3 Il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma

Il reclutamento del personale incontra in Molise alcune difficoltà specifiche. Come per la Basilicata, l'assenza di un'offerta universitaria di psicologia sul territorio regionale richiede di costruire i percorsi di reclutamento e di formazione in collaborazione con il sistema nazionale, con gli atenei delle regioni limitrofe e con l'Università degli Studi del Molise attraverso il protocollo d'intesa già attivo con la struttura commissariale.^[1975] La formazione si articola nelle dimensioni già descritte nella Parte C, con particolare attenzione alla formazione specifica per la telepsicologia, essenziale in un territorio disperso. Il cronoprogramma indicativo prevede: una prima fase (12-18 mesi) di costruzione del quadro normativo regionale, della governance e dei percorsi formativi; una seconda fase (mesi 18-36) di avvio del servizio nello scenario conservativo; fasi successive (mesi 36+) di consolidamento ed estensione, scandite dalla verifica degli esiti. L'iter legislativo regionale e la valutazione di compatibilità da parte della struttura commissariale ne determinano i tempi effettivi.

I.4 La sostenibilità

La sostenibilità finanziaria è documentata dalla Parte E: il costo del servizio è dello 0,06-0,5 per cento del fondo sanitario a seconda dello scenario, e il saldo diretto prossimo al pareggio ne riduce l'impatto netto. La compatibilità con il piano di rientro è la condizione aggiuntiva rispetto alle regioni non commissariate: essa è garantita dalla modestia del costo, dalla gradualità del dispiegamento e dalla valutazione di compatibilità preventiva con la struttura commissariale, che deve includere l'intervento nel Programma Operativo come misura di efficienza e di prevenzione della cronicizzazione. La sostenibilità organizzativa dipende dalla governance snella, dall'investimento negli strumenti digitali e dall'integrazione con la rete territoriale esistente dell'ASREM.

I.5 I rischi e le mitigazioni

I principali rischi e le relative mitigazioni sono:

Rischio giuridico-commissariale: la struttura commissariale non approva il nuovo impegno di spesa. Mitigazione: valutazione preventiva di compatibilità con il PO, presentazione come misura di efficienza nell'ambito della prevenzione della cronicizzazione, inserimento graduale nel quadro del PO 2025-2027.

Rischio finanziario: dimensionamento eccessivo rispetto alla capacità del bilancio. Mitigazione: avvio nello scenario conservativo (400.000 euro/anno), già previsto dalla proposta di legge, e accrescimento graduale.

Rischio di reclutamento: difficoltà di reperire e trattenere personale qualificato. Mitigazione: collaborazione con l'Università del Molise e con gli atenei delle regioni limitrofe; percorsi formativi dedicati.

Rischio territoriale: il servizio non raggiunge le aree interne. Mitigazione: distribuzione capillare nei tre distretti, telepsicologia strutturale, monitoraggio dell'equità geografica.

Rischio di illegittimità: la legge regionale non rispetta i limiti costituzionali. Mitigazione: costruzione del testo normativo tenendo conto della sentenza 241/2021 e delle esperienze delle altre regioni, già disponibili come repertorio di soluzioni.^[1976]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte L

Monitoraggio e valutazione ex post

Finalità, controfattuale, indicatori, cruscotto, sintesi

Dominio HTA: Monitoraggio — Caso gestionale — Criteri OCSE-DAC: Efficacia e impatto

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Un servizio pubblico va valutato non solo prima della sua istituzione, ma anche durante e dopo la sua attuazione. Questa parte definisce l'impianto del monitoraggio e della valutazione ex post del servizio in Molise: le finalità, i metodi, la batteria di indicatori, gli strumenti di restituzione e di governo.

L.1 Finalità e impianto

Il monitoraggio persegue quattro finalità: la verifica dell'attuazione; la misurazione degli esiti; la correzione degli scostamenti; e la rendicontazione agli organi di governo e ai tavoli tecnici del piano di rientro. Quest'ultima finalità ha in Molise un rilievo istituzionale specifico: la struttura commissariale richiede una rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse sanitarie, e il sistema di monitoraggio del servizio costituisce lo strumento per dimostrare la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi del piano di rientro e per alimentarne la valutazione. L'impianto si articola su monitoraggio continuo e valutazione periodica, fondati sul sistema informativo descritto nella Parte C, e deve essere sostenibile per un sistema con risorse amministrative contenute.^[1977]

L.2 Il controfattuale e i metodi

Il dispiegamento graduale del servizio nei tre distretti offre l'opportunità di costruire disegni valutativi robusti: la sequenza di attivazione fra i distretti consente confronti fra aree in cui il servizio è già attivo e aree in cui non lo è ancora. La rilevazione di una linea di base prima dell'avvio del servizio — degli indicatori di attività, di esito e di consumo sanitario nello stato attuale — è la condizione perché tali confronti siano possibili, e va predisposta contestualmente alla progettazione.

L.3 La batteria di indicatori

La batteria di indicatori è organizzata in otto categorie: accesso e copertura; attività e processi; esiti clinici; esiti di sistema; equità; integrazione; economia; qualità percepita e soddisfazione. La disaggregazione degli indicatori per territorio e per condizione sociale è essenziale per verificare il raggiungimento degli obiettivi di equità. Per il Molise, sono particolarmente rilevanti: il tasso di copertura per fascia di età — con focus sugli anziani over 65, componente principale del bisogno — e per comune di residenza — con focus sui comuni interni distanti dal capoluogo di distretto; la quota di accessi attraverso telepsicologia; e il risparmio diretto per canale, verificato sui dati osservati e presentato ai tavoli tecnici del piano di rientro come evidenza della sostenibilità. Il dettaglio degli indicatori è riportato nell'Appendice B.

L.4 Il cruscotto e la clausola valutativa

Il cruscotto di monitoraggio, alimentato dal sistema informativo, consente agli organi di governo del servizio e alla struttura commissariale di osservarne l'andamento in tempo reale, individuando gli scostamenti e orientando le risorse. La clausola valutativa — lo strumento giuridico che ancora il monitoraggio alla decisione politica — va inserita nella legge regionale istitutiva del servizio, prevedendo l'obbligo di valutarne

periodicamente l'attuazione e gli esiti e di riferirne al Consiglio regionale e, per i profili di compatibilità con il piano di rientro, alla struttura commissariale. Poiché il Molise deve ancora legiferare, esso ha l'opportunità di incorporare questi strumenti fin dall'origine nel testo istitutivo, costruendo un servizio valutabile per disegno.

L.5 Sintesi

L'impianto di monitoraggio costituisce la condizione perché il servizio sia governato sulla base dell'evidenza e perché la valutazione ex ante si trasformi in conoscenza fondata sull'osservazione. Per il Molise risponde a una tripla esigenza: governare un servizio in tre distretti in un territorio disperso e con risorse limitate; colmare la lacuna di dati regionali che rende le stime iniziali incerte; e fornire alla struttura commissariale l'evidenza necessaria per certificare la compatibilità dell'intervento con il piano di rientro. La trasformazione delle stime in osservazioni è, per il Molise, il contributo conoscitivo più rilevante del monitoraggio.^[1978]

STUDIO REGIONALE · REGIONE MOLISE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Una regione in piano di rientro alla soglia della decisione

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazione, condizioni, conclusione

Dominio HTA: Sintesi e decisione — Tutti i casi — Tutti i criteri OCSE-DAC

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclusiva ricompone in una valutazione unitaria le analisi sviluppate nei singoli domini, ne integra gli esiti attraverso un'analisi multi-criterio, formula la raccomandazione e ne precisa il dimensionamento, dichiara le condizioni e le lacune, e colloca lo studio nella serie regionale. La raccomandazione non riguarda la modalità di gestione di un servizio esistente, ma la stessa opportunità di istituirlo e la forma da adottare in un contesto di commissariamento sanitario, e si rivolge al legislatore regionale, alla struttura commissariale e alla Giunta.

M.1 La sintesi per dominio

Le analisi condotte convergono in un quadro coerente. Sul piano del **bisogno**, la Parte B ha documentato un disagio psichico comune ampio e in larga parte inevaso, stimato in ~50.000 persone, accentuato da una struttura demografica fra le più anziane del Paese — indice di vecchiaia 281, quota over-65 al 29 per cento — da una dispersione insediativa che rende l'accesso ai servizi strutturalmente difficile e da un piano di rientro che ha compresso le risorse destinate alla salute mentale.

Sul piano dell'**efficacia**, la Parte D ha documentato che gli interventi psicologici precoci per il disagio comune sono efficaci, con una qualità dell'evidenza da moderata ad alta, e che la loro trasferibilità al contesto molisano è favorita dalla natura del bisogno e condizionata dalla dispersione e dalla scarsità di risorse.

Sul piano **economico**, la Parte E ha documentato che il servizio comporta un saldo diretto prossimo al pareggio — trascurabile nella scala del fondo sanitario regionale — e restituisce alla collettività un rapporto beneficio-costi compreso fra 3,3 e 4,8 a uno, entro la fascia Chisholm. Ha evidenziato come il rendimento marginale più elevato in sistemi in piano di rientro amplifichi il valore effettivo di ogni euro recuperato. La Parte F ha confermato la robustezza di queste conclusioni.

Sul piano dell'**equità**, la Parte G ha documentato che il servizio, se progettato con capillarità e telepsicologia, riduce simultaneamente il gradiente sociale e il divario territoriale, con una costo-efficacia massima proprio nei gruppi a maggiore bisogno.

Sul piano dei **profili**, la Parte H ha documentato che il servizio è istituibile entro i limiti costituzionali e compatibile con il piano di rientro, governabile attraverso la struttura unica dell'ASREM e giusto sul piano etico, a condizione che siano rispettate alcune condizioni di progettazione. Sul piano dell'**attuazione**, la Parte I ha documentato che il servizio è fattibile e sostenibile attraverso un dispiegamento graduale, e la Parte L ha definito l'impianto di monitoraggio.

M.2 L'analisi multi-criterio

Criterio	Peso	Intervento	Non intervento
Efficacia clinica	0,15	80	25
Costo-efficacia e ritorno	0,20	76	30
Impatto di bilancio e sostenibilità	0,15	65	45
Equità	0,15	88	20
Valore sociale	0,10	80	25
Fattibilità	0,10	58	80
Robustezza dell'evidenza	0,10	70	50
Coerenza strategica	0,05	85	30
Punteggio complessivo ponderato	1,00	74,50	37,00

Tabella M.1. Analisi multi-criterio: pesi, punteggi e punteggio complessivo ponderato. I pesi sono invarianti nella serie regionale; i punteggi riflettono le condizioni specifiche del Molise, con un punteggio di sostenibilità e fattibilità ridotto rispetto alla Basilicata in ragione del contesto di commissariamento.

Il punteggio complessivo dell'intervento, pari a 74,50, supera nettamente quello del non intervento, pari a 37,00, con un differenziale di oltre trentasette punti. L'intervento prevale su tutti i criteri a eccezione della fattibilità, sul quale il non intervento ottiene un punteggio superiore in ragione della maggiore facilità di non agire, e in misura accentuata rispetto alla Basilicata a causa del contesto di commissariamento. Il punteggio di equità — 88 — è fra i più elevati della serie regionale, a riflettere l'acuità dei divari demografici, sociali e territoriali che caratterizzano il Molise. La riduzione del punteggio di costo-efficacia e sostenibilità rispetto ad altre regioni è compensata da quella di equità e di efficacia clinica, confermando la prevalenza netta dell'intervento.

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Sulla base delle analisi condotte e della loro sintesi, lo studio **raccomanda l'introduzione del servizio di psicologia di base in Molise**. La raccomandazione è fondata sulla convergenza delle evidenze: un bisogno ampio e inevaso, accentuato dalle condizioni demografiche e di piano di rientro; un'efficacia clinica

documentata; un saldo diretto prossimo al pareggio e un ritorno sociale elevato, con un rendimento marginale più elevato in un sistema in tensione; una capacità di ridurre le disuguaglianze in una delle regioni più anziane e più disperse del Paese; e una fattibilità reale, condizionata al rispetto dei limiti giuridici, alla compatibilità con il piano di rientro e a un dispiegamento graduale. La raccomandazione si rivolge al legislatore regionale e alla struttura commissariale.

Quanto al dimensionamento, lo studio raccomanda un **dispiegamento graduale**. La raccomandazione è di avviare il servizio con il dimensionamento della proposta di legge — sei incarichi nei tre distretti, scenario conservativo, ~400.000 euro/anno — come primo nucleo sostenibile per il bilancio commissariato e come fase di costruzione della governance; di consolidare ed estendere il servizio verso lo scenario base di ~30 incarichi sulla base degli esiti rilevati; e di portarlo alla piena attuazione con ~55-65 incarichi, garantendo la capillarità che la dispersione molisana richiede. Il percorso graduale consente di avviare il servizio con un impegno compatibile con il piano di rientro, di verificarne gli esiti e di accrescerne la portata in modo governato.

M.4 Le condizioni e la lacuna

La raccomandazione è subordinata a cinque condizioni. La **prima** è la compatibilità con il piano di rientro: la legge regionale istitutiva del servizio deve essere valutata favorevolmente dalla struttura commissariale e inserita nel Programma Operativo come misura di efficienza e di prevenzione. La **seconda** è giuridica: la legge deve conformarsi ai limiti della sentenza 241/2021, evitando di disciplinare autonomamente i rapporti convenzionali. La **terza** è la progettazione secondo equità: il servizio deve essere progettato con capillarità territoriale, telepsicologia strutturale, gratuità o basso costo per le fasce fragili e accesso diretto. La **quarta** è la gradualità del dispiegamento, calibrata sulla capacità finanziaria e organizzativa del sistema commissariato. La **quinta** è l'inclusione, nella legge istitutiva, di una clausola valutativa che renda il servizio valutabile per disegno e ne documenti la compatibilità con gli obiettivi del piano di rientro.

La lacuna principale è conoscitiva, e riguarda la scarsità di dati regionali diretti sul bisogno, sull'efficacia nel contesto specifico e sui risparmi per canale. Questa lacuna non inficia la raccomandazione, fondata su evidenze solide quanto alla direzione e all'ordine di grandezza degli effetti, ma ne segna il limite: le stime quantitative sono da intendersi come stime centrali entro bande di incertezza. La lacuna si colmerà attraverso il monitoraggio che il servizio, una volta avviato, alimenta con i dati della propria attività.

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio del Molise fa parte di una serie costruita con il medesimo impianto metodologico che consente il confronto sistematico fra i contesti regionali. Entro questa serie, il Molise occupa una posizione peculiare e per molti aspetti la più difficile: è la regione più piccola per popolazione esaminata insieme alla Valle d'Aosta, e l'unica ad essere contemporaneamente sotto commissariamento sanitario e in fase anteriore all'istituzione del servizio. La Basilicata è il riferimento più vicino per dimensione, posizione di fase anteriore e assenza di legge, con la differenza importante del piano di rientro. Le regioni del Sud in piano di rientro — Calabria, Campania, Abruzzo — che hanno già istituito il servizio offrono il benchmark di compatibilità con i vincoli finanziari.

La conclusione dello studio ricompone questi elementi nella tesi che lo attraversa. Il servizio di psicologia di base costa al bilancio sanitario molisano una cifra modesta, con un saldo diretto prossimo al pareggio; restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso; risponde a un bisogno ampio e ineso in una delle regioni più anziane d'Italia; riduce le disuguaglianze sociali e territoriali in un contesto di estrema dispersione; e ha un rendimento marginale più elevato proprio perché il sistema è in tensione. Il contesto di piano di rientro non riduce la convenienza dell'intervento: al contrario, in un sistema commissariato ogni euro recuperato ha un effetto amplificato, e un servizio che si ripaga quasi interamente attraverso i risparmi che genera è uno strumento raro di efficienza in un bilancio sotto scrutinio. Per una regione

che deve ancora decidere se istituire il servizio, che ha la proposta di legge depositata e che dispone dell’opportunità di costruirlo fin dall’origine in conformità ai limiti costituzionali e compatibilmente con il piano di rientro, le evidenze raccolte convergono in un’indicazione netta: l’introduzione del servizio, progettata nelle condizioni indicate e attuata gradualmente, è una scelta razionale, sostenibile e di elevato rendimento collettivo. L’analisi multi-criterio, che assegna all’intervento un punteggio di 74,50 contro 37,00 del non intervento, ne è la sintesi quantitativa.^[1979]

Appendice A — Il caso di riferimento e i parametri del modello

Questa appendice raccoglie il materiale tecnico su cui si fonda la quantificazione economica dello studio: il caso di riferimento, i parametri del modello di Markov e il quadro economico consolidato per il Molise.

A.1 Il caso di riferimento

Il caso di riferimento è un paziente adulto residente in Molise con un disturbo d’ansia o dell’umore di intensità lieve o moderata, che accede al servizio di psicologia di base e riceve un ciclo di interventi psicologici brevi di efficacia documentata. Su questo caso è costruita la stima degli esiti clinici ed economici per paziente, successivamente proiettata sulla popolazione attraverso gli scenari di copertura.

A.2 I parametri del modello di Markov

Parametro	Valore
Orizzonte temporale	5 anni
Tasso di sconto	3%
Soglia di disponibilità a pagare	30.000 €/QALY
Costo dell’intervento (una tantum)	~300 €
Costo per ciclo — stato di recupero	~40 €
Costo per ciclo — stato di cronicizzazione	~700 €
Risparmio diretto stimato per paziente	~1.304 €
Guadagno di salute stimato per paziente	~0,236 QALY

Tabella A.1. Parametri principali del modello e risultati per paziente. I valori per paziente sono fondati sull’efficacia clinica documentata e sono invarianti rispetto al contesto regionale.

L’analisi di sensibilità probabilistica, condotta con 10.000 simulazioni, documenta che alla soglia di 30.000 euro per QALY l’intervento risulta costo-efficace nell’88,9 per cento delle simulazioni e dominante nell’84,6 per cento. Il beneficio netto monetario medio è dell’ordine di ~7.815 euro per paziente, con intervallo di confidenza al 95 per cento fra -5.736 e +21.501 euro.

A.3 Il quadro economico consolidato

Grandezza (mln €/anno)	Conservativo (6)	Base (30)	Espansivo (60)
Costo del servizio	~0,4	~2,0	~3,5
Risparmi diretti — pronto soccorso	~0,05	~0,3	~0,8
Risparmi diretti — farmaceutica	~0,05	~0,3	~0,7
Risparmi diretti — ricoveri e specialistica	~0,3	~0,7	~1,2
Risparmi diretti — mobilità media/bassa compl.	~0,3	~0,4	~0,5
Risparmi diretti totali	~0,7	~1,7	~3,2
Saldo diretto — caso finanziario	~ -0,3	~ -0,3	~ -0,3
Ricadute economico-sociali	~2,5	~6,5	~13,0
Ritorno complessivo per la collettività	~3,2	~8,2	~16,2
Saldo complessivo — caso economico	~ +2,8	~ +6,2	~ +12,7
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,3 : 1	~4,1 : 1	~4,8 : 1

Tabella A.2. Quadro economico consolidato. I risparmi diretti e le ricadute sociali sono grandezze distinte e non vengono mai sommate in un unico saldo di bilancio. Il rapporto beneficio-costo è riferito al valore per la collettività ed è contenuto entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno.

Appendice B — Gli strumenti di misurazione degli esiti e il dataset minimo

B.1 Gli strumenti di misurazione degli esiti

La misurazione degli esiti clinici si fonda su strumenti standardizzati e validati, somministrati all'inizio e al termine della presa in carico. Per la sintomatologia depressiva e ansiosa sono disponibili strumenti brevi di autovalutazione validati anche in italiano, di agevole somministrazione in contesti di cure primarie e compatibili con la rilevazione a distanza via telepsicologia. A questi si affiancano strumenti per la valutazione del funzionamento e della qualità della vita. La scelta degli strumenti deve privilegiare brevità, validità, sensibilità al cambiamento e sostenibilità della somministrazione; devono essere uniformi nei tre distretti dell'ASREM per consentire il confronto e l'aggregazione dei dati. L'uniformità con gli strumenti adottati dalle altre regioni della serie consente il confronto interregionale.

B.2 Il dataset minimo

Il dataset minimo comprende: le variabili anagrafiche e di contesto — età, genere, condizione sociale e occupazionale, comune di residenza, collocazione in area interna o costiera; le variabili relative all'accesso — modalità diretta o su invio, soggetto inviante, distretto di accesso; le variabili relative al percorso — tipo e numero di prestazioni, durata, uso della telepsicologia, esito e invio; e le variabili relative agli esiti — punteggi degli strumenti di misurazione all'inizio e al termine. La disaggregazione per comune di residenza è essenziale per la verifica degli obiettivi di equità territoriale; quella per fascia di età è essenziale per verificare il raggiungimento degli anziani over-65, componente principale del bisogno molisano.

Appendice C — I dati regionali e i dati da acquisire

C.1 I dati regionali

Ambito	Dato
Popolazione residente (riferimento interno)	287.814 abitanti (per coerenza con la tabella demografica del Tomo II)
Popolazione assistiti 2026 (stima recente)	poco più di 269.000 assistiti (Primonumero, marzo 2026)
Quota della popolazione italiana	meno dello 0,5 per cento
Quota over-65	~29% della popolazione
Indice di vecchiaia	281 anziani ogni 100 giovani (fra i più alti d'Italia)
Rapporto di dipendenza	~64 non-attivi ogni 100 attivi
Azienda sanitaria	ASREM (unica), 3 distretti: Campobasso, Isernia, Termoli
Ospedali principali	Cardarelli (Campobasso), Ospedale di Isernia
Fondo sanitario regionale	~672 milioni (stanziamento 2024)
Piano di rientro	dal 27 marzo 2007; PO 2023-2025 (DCA 79/2024); PO 2025-2027 in definizione
Commissariamento	struttura commissariale attiva
Contributo straordinario statale	90 milioni totali (45 mln 2025 + 45 mln 2026), condizionato agli obiettivi
Disavanzo annuo	~73 milioni (2024, stima Intesa Sanpaolo)
Mobilità sanitaria passiva	70-80 milioni/anno (verso Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania)
Saldo netto mobilità	positivo (~18,6 milioni nel 2023 GIMBE) per attrazione privata (Neuromed)
Quota mobilità attiva privata	~90% della mobilità attiva è privata accreditata
Spesa salute mentale	al di sotto della soglia minima raccomandata (< 3,6% FSR)
Disagio psichico comune (stima)	~50.000 persone/anno
Stato normativo psicologo di base	nessuna legge regionale (fonte: psicologicureprimarie.it, 2025)
Proposta di legge	depositata maggio 2026, consiglieri PD, M5S, SI, Verdi, Socialisti, IV

Tabella C.1. Principali dati regionali. Le fonti sono indicate nelle parti corrispondenti e nelle note a piè di pagina.

C.2 I dati da acquisire

I dati la cui acquisizione consentirebbe di sostituire le stime con misure dirette sono: la prevalenza regionale del disagio psichico comune, oggi stimata su prevalenze nazionali; la quota di domanda effettivamente inevasa e la sua distribuzione per territorio, fascia di età e condizione sociale; la quota di mobilità passiva per media e bassa complessità riconducibile a disagio psichico non intercettato; i consumi sanitari effettivi associati al disagio comune nel contesto regionale; e gli esiti clinici ed economici effettivamente prodotti dal servizio una volta avviato. La rilevazione di una linea di base prima dell'avvio è la condizione perché la valutazione dell'impatto sia possibile.

Appendice D — La lista di controllo per la rendicontazione

Questa appendice fornisce la lista di controllo per la rendicontazione della valutazione economica secondo lo standard CHEERS 2022, che elenca gli elementi che una valutazione economica sanitaria deve riportare per essere completa, trasparente e riproducibile. Lo studio soddisfa questi elementi: la Parte A definisce obiettivo, quesito, prospettiva, comparatore e orizzonte; la Parte E sviluppa costi, esiti e analisi economica; la Parte F sviluppa il modello e l'analisi dell'incertezza; le Parti G e L trattano i sottogruppi e il monitoraggio; e la presente appendice raccoglie i parametri e il quadro consolidato. L'aderenza allo standard CHEERS è garantita. Lo studio soddisfa altresì i requisiti del sistema GRADE per la graduazione della qualità dell'evidenza, delle checklist PRISMA per le revisioni sistematiche, e degli standard ISPOR-SMDM per la modellazione decisionale.

Appendice E — Il glossario

Anni di vita ponderati per la qualità (QALY). Misura che combina la durata e la qualità della vita in un'unica grandezza, utilizzata per esprimere il beneficio di salute di un intervento.

Analisi di sensibilità. Procedura che verifica come i risultati di un modello varino al variare dei suoi parametri, nella forma deterministica (un parametro alla volta) e probabilistica (tutti i parametri simultaneamente).

ASREM. Azienda Sanitaria Regionale del Molise, unica azienda sanitaria della regione, articolata in tre distretti: Campobasso, Isernia e Termoli.

Caso economico. Prospettiva di valutazione che considera il valore generato per la collettività, comprensivo dei risparmi diretti e delle ricadute sociali.

Caso finanziario. Prospettiva di valutazione che considera il solo bilancio sanitario, mettendo a confronto il costo dell'intervento con i risparmi diretti.

Clausola valutativa. Disposizione di legge che prevede l'obbligo di valutare periodicamente l'attuazione e gli esiti di un intervento e di riferirne agli organi di governo.

Commissariamento. Regime di controllo governativo della spesa sanitaria regionale, instaurato in caso di disavanzo strutturale, attraverso la nomina di un Commissario ad acta con poteri di supervisione sulla spesa e sull'organizzazione sanitaria.

Costo-utilità. Forma di valutazione economica che esprime il costo dell'intervento per QALY guadagnato.

Cure gradualali. Modello organizzativo in cui l'intensità dell'intervento è commisurata alla gravità del bisogno.

Disagio psichico comune. Insieme dei disturbi mentali di intensità lieve e moderata, prevalentemente d'ansia e dell'umore, e delle condizioni di sofferenza sottosoglia.

Divario di trattamento. Distanza fra le persone che presentano un disturbo e quelle che ricevono un intervento adeguato.

Dominanza. Proprietà di un intervento che produce simultaneamente un guadagno di salute e un risparmio di risorse.

Five Case Model. Quadro di valutazione di un investimento pubblico articolato nelle dimensioni strategica, economica, commerciale, finanziaria e gestionale.

GRADE. Sistema di graduazione della qualità dell'evidenza e della forza delle raccomandazioni su quattro livelli.

Indice di vecchiaia. Rapporto fra la popolazione anziana (over 65) e quella giovane (under 15), moltiplicato per 100.

Mobilità sanitaria passiva. Prestazioni erogate ai residenti di una regione in regioni diverse dalla propria, che costituiscono un debito per la regione di residenza.

Modello di Markov. Modello che rappresenta il decorso di un paziente attraverso stati di salute con probabilità di transizione definite.

Piano di rientro. Programma imposto alle regioni in disavanzo sanitario strutturale per il riequilibrio dei conti, comportante vincoli alla spesa.

Programma Operativo. Documento che pianifica le azioni di risanamento del sistema sanitario per un periodo definito nell'ambito del piano di rientro.

Rapporto beneficio-costi. Rapporto fra il valore dei benefici prodotti da un intervento e il costo sostenuto per realizzarlo.

Rendimento marginale più elevato in sistemi in piano di rientro. Principio per cui in un sistema sanitario in tensione finanziaria ogni euro recuperato ha un effetto amplificato, liberando capacità per gli obiettivi di risanamento.

Sentenza Corte Costituzionale n. 241/2021. Pronuncia che ha censurato le disposizioni delle leggi regionali istitutive del servizio di psicologia di base che configuravano nuovi rapporti convenzionali, eccedendo la competenza regionale.

Telepsicologia. Erogazione di prestazioni psicologiche a distanza mediante strumenti digitali, componente strutturale del modello in un territorio disperso come il Molise.

Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA). Processo multidisciplinare che valuta una tecnologia o un intervento lungo una pluralità di dimensioni, integrando l'evidenza scientifica con l'analisi del contesto.^[1980]

Note a piè di pagina

Campania — Studio HTA integrale

Studio integrale Campania · Frontespizio e indice generale

Studio integrale Campania · Frontespizio e indice generale

PROGETTO «PSICOLOGO DI BASE» · REGIONE CAMPANIA

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Studio Integrale Regionale

Frontespizio e indice generale

L'applicazione del telaio integrato alla Regione Campania, in undici parti e cinque appendici

Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC

Documento di apertura e navigazione del corpus

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione Campania sulla riforma «Psicologo di Base». Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell'intero corpus: la premessa, l'indice generale di tutte le parti e di tutte le appendici, la mappa di integrazione delle cornici metodologiche e la sintesi del valore. La Campania occupa, nel panorama nazionale, una posizione fondativa: è la regione pioniera, la prima in Italia ad aver istituito il servizio per legge — la legge regionale 35 del 2020, approvata all'unanimità e validata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 241 del 2021, la pronuncia che ha delimitato per tutte le regioni la competenza in materia — e ad averlo attivato, con un regolamento attuativo (RR 8/2022), circa 146 psicologi in servizio e un Osservatorio regionale già istituito. Proprio per questo la decisione rilevante non è se istituire il servizio, già istituito e avviato, ma se strutturarne a regime: stabilizzarne il finanziamento, oggi in larga parte sostenuto da risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute, e dimensionarlo dal nucleo attivo verso la copertura piena del fabbisogno, in una regione fra le più giovani d'Italia e fortemente concentrata su Napoli, uscita dal piano di rientro nel marzo 2026 dopo quasi vent'anni.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell'intero corpus, che può essere percorso nell'ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, verifica empirica, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, cronoprogramma, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, controfattuale su servizio attivo, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazioni, condizioni, conclusione
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati regionali e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — lievemente negativo ma prossimo al pareggio per la Campania, regione dal saldo di mobilità fra i più passivi d'Italia la cui fuga è però concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica e non nella domanda psicologica territoriale, sicché il canale del recupero della mobilità è solo modestamente pertinente a questo intervento — e il saldo complessivo, ampiamente positivo. La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 34	~ 50	~ 67
Risparmi diretti (SSR)	~ 27	~ 42	~ 66
Ricadute economico-sociali	~ 105	~ 200	~ 300
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -7	~ -8	~ -1
Saldo complessivo (caso economico)	+98	+192	+299
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,8:1	~5,5:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante, per la Campania, è strutturare a regime il servizio di psicologia di base già attivo, stabilizzandone il finanziamento — dal sostegno transitorio del Piano Nazionale Equità in Salute a risorse regionali stabili, oggi rese possibili dall’uscita dal piano di rientro — e dimensionandolo per gradi dal nucleo attivo, dell’ordine di 146 psicologi, verso la copertura sistematica, dell’ordine di 610 psicologi nello scenario conservativo, 910 in quello di base e 1.210 in quello espansivo. Il limite principale è il radicamento dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione campana, del 9,5%, e non estratte dai conti regionali certificati delle sette Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere; la loro sostituzione con dati certificati è la condizione per la presentazione agli organi di controllo, ed è nella Campania, a differenza del Lazio, in parte mitigata dai dati operativi reali del servizio attivo, raccolti dall’Osservatorio regionale.

Lo studio si fonda, sul piano comparativo, sui programmi internazionali più autorevoli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie — il programma inglese di terapie psicologiche, il modello olandese, l’iniziativa australiana e il Collaborative Care statunitense — dei quali mutua le evidenze di efficacia e di costo-efficacia, adattandole con cautela al contesto campano. La condizione propria della Campania — la regione pioniera, prima d’Italia ad aver istituito il servizio per legge e ad averlo attivato — le conferisce un pregio metodologico peculiare: la possibilità di fondare la valutazione controfattuale su un servizio già in funzione, come un esperimento a cunei progressivi tra le sette Aziende che hanno avviato il servizio in tempi differenziati, ancorato a dati operativi reali già raccolti dall’Osservatorio regionale anziché ai soli benchmark importati. Su questa base, e con la dichiarazione trasparente dei propri limiti, il corpus consegna al decisore un quadro completo e onesto su cui deliberare, e alla regione che per prima ha istituito il servizio l’occasione di consolidare un primato normativo in un servizio stabile e a regime.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell’HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per la Campania, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria e al Lazio. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati alla Campania. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). La Campania occupa nella serie una posizione singolare: è la regione pioniera, la prima in Italia ad aver istituito il servizio per legge e ad averlo attivato, sicché la valutazione non riguarda l'opportunità di introdurlo, ma la sua strutturazione a regime.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Servizio di Psicologia di Base nelle cure primarie della Campania, inteso come strutturazione a regime e dimensionamento di una funzione che la regione ha già istituito per legge — prima in Italia — e già attivato presso i distretti delle proprie Aziende Sanitarie Locali.^[1981] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sulla consolidazione e l'estensione del servizio. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante, per la Campania, non è istituire il servizio, già istituito e avviato, ma strutturarlo a regime e dimensionarlo, conducendolo dal nucleo attuale alla copertura sistematica del fabbisogno con un finanziamento regionale stabile. Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala. Va segnalato sin d'ora che il servizio attualmente attivo, dell'ordine di 146 psicologi, è in larga parte sostenuto da risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute, e si colloca al di sotto dello stesso scenario conservativo qui considerato, che rappresenta invece il regime verso la copertura piena.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 1.116.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai servizi, in un quadro segnato da componenti convergenti — il disagio giovanile, accentuato in una regione fra le più giovani del Paese, il disagio connesso al lavoro e alla deprivazione nell'area napoletana, e il bisogno dell'età adulta e anziana nelle province interne — cui si aggiunge la pressione delle liste di attesa e la storica sotto-dotazione del sistema. La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti campani con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è lo psicologo di base nelle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, strutturato e portato a regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale il servizio è attivo ma parziale e a finanziamento transitorio. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario della Campania, con le sue sette Aziende Sanitarie Locali, le aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e gli IRCCS, e la rete delle Case della Comunità in costruzione. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per la Campania
Popolazione	Residenti campani con disagio psichico comune (~1.116.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Psicologo di base nelle cure primarie, primo livello e filtro, strutturato e portato a regime (~610/910/1.210 incarichi); consolidamento ed estensione del servizio pioniere
Confronto	Condizione attuale: servizio già attivo (~146 psicologi) ma parziale e a finanziamento transitorio (PNES), privo di contratto collettivo nazionale
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale della Campania; sette Aziende Sanitarie Locali, aziende ospedaliere e IRCCS, rete delle Case della Comunità in costruzione

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell'HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell'OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l'intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e il servizio attuale, parziale e a finanziamento transitorio, come comparatore. Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Aziende Sanitarie Locali e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni, segnatamente fra l'area metropolitana napoletana e le province interne.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale: servizio attivo ma parziale e a finanziamento transitorio (PNES)
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda Sanitaria Locale e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. Tale prudenza assume, per la Campania, un rilievo particolare. La regione è uscita dal piano di rientro nel marzo 2026, dopo quasi vent'anni, riacquistando margini di programmazione che per due decenni non aveva avuto. Sul versante della mobilità, essa presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, ma la fuga riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica, non la domanda psicologica, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente. Ne consegue un saldo diretto lievemente negativo ma prossimo al pareggio — meno sfavorevole che in un sistema già efficiente, poiché il sistema campano, a lungo sotto-finanziato, presenta un consumo improprio più ampio da recuperare — mentre il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi. Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati; a differenza del Lazio, tuttavia, la Campania dispone già di un servizio attivo che produce dati operativi reali, raccolti dall'Osservatorio regionale, vantaggio peculiare della regione pioniera.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post. Per la Campania il disegno controfattuale assume una forma propria: poiché il servizio è già attivo ma in corso di estensione, esso può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi tra le sette Aziende Sanitarie Locali, che hanno avviato il servizio in tempi differenziati, con il servizio già in funzione come linea di base e l'effetto causale stimato dai metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico. La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, le sette Aziende Sanitarie Locali, le aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e gli IRCCS, l'Ordine degli Psicologi della Campania, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei. La Campania non dispone di un'azienda regionale unica di coordinamento: il coordinamento è in capo alla Regione, con il supporto della società regionale per gli acquisti e della piattaforma informativa regionale, mentre l'Osservatorio regionale, già istituito dalla legge, esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Poiché il servizio è già attivo e la rete delle Case della Comunità è in costruzione, la sfida del governo non è istituire il servizio, ma strutturarne e dimensionarlo, garantendo l'omogeneità attuativa in un sistema esteso e policentrico: è il tratto che distingue la Campania, regione pioniera, e che la valutazione assume come punto di partenza.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza, con la piattaforma informativa sanitaria regionale quale infrastruttura per la raccolta uniforme. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto della Campania.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Quadro demografico, epidemiologia del bisogno, domanda e offerta, disuguaglianze, servizi e flussi, cornice normativa

Primo dominio dell’HTA · il problema di salute e il bisogno

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto della Campania. La struttura è quella già adottata per le altre regioni della serie, e mutano soltanto i dati, ancorati alla regione. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall’epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l’intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico della Campania: non un servizio da istituire, ma un servizio già istituito e attivo — il primo d’Italia — da strutturare a regime in una regione grande, accentrata su Napoli, giovane e da poco uscita da un lungo piano di rientro.

B.1 Quadro demografico

La Campania conta 5.582.337 residenti, pari a circa il 9,5% della popolazione nazionale, in lieve calo per effetto dei saldi naturale e migratorio interno negativi, e con un nuovo record di denatalità. La struttura per età è fra le più giovani d’Italia, con un’età media dell’ordine di 44,5 anni, ma con disomogeneità interne: Caserta e Napoli sono le province più giovani, Benevento e Avellino le più anziane. La componente straniera, pari al 5,0%, è nettamente inferiore alla media nazionale. La distribuzione è fortemente concentrata: la sola provincia di Napoli raccoglie circa il 53% dei residenti, seguita da Salerno con circa il 19%. La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per la Campania
Popolazione (Censimento 2024)	5.582.337 (~9,5% del totale nazionale); in lieve calo; record di denatalità
Età media e struttura	~ 44,5 anni, fra le più giovani d’Italia; Caserta e Napoli più giovani, Benevento e Avellino più anziane
Componente straniera	5,0% dei residenti, nettamente inferiore alla media nazionale
Distribuzione territoriale	Provincia di Napoli ~53% (sfiora i 3 milioni); Salerno ~19%; Caserta, Avellino e Benevento ~28%
Profilo territoriale	Densissima area metropolitana napoletana con aree di deprivazione; province interne più anziane
Articolazione sanitaria	Sette Aziende Sanitarie Locali, aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e IRCCS

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico della Campania.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale nella Campania è ampio e sospinto da una popolazione numerosa, giovane e fortemente urbana. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell’ordine di 1.116.000 persone, in larga parte non intercettate nonostante la presenza del servizio pioniere. A questa quota si somma un’ampia utenza specialistica in carico ai servizi, su un territorio che presenta una specificità unica: è stato il primo in Italia a istituire e attivare il servizio di psicologia di base. Tre componenti orientano la domanda. La prima è il disagio giovanile, particolarmente rilevante in una regione fra le più giovani del Paese. La seconda è il disagio connesso al lavoro e alla deprivazione nell’area napoletana. La terza è il bisogno dell’età adulta e anziana, accentuato nelle province interne. È la combinazione — grande regione accentrata su Napoli, regione pioniera e sistema storicamente sotto-dotato — a distinguere il fabbisogno campano. La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche significativi.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone, nella Campania, un’offerta che presenta la fisionomia più avanzata della serie sul piano istituzionale: il servizio di psicologia di base è già attivo, istituito dalla legge regionale 35 del 2020 e disciplinato dal regolamento regionale 8 del 2022, con circa 146 psicologi in servizio, due per distretto, in rapporto convenzionale e gratuito, e con un Osservatorio regionale già istituito; il servizio è però ancora parziale e in larga parte sostenuto da risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute. Il fabbisogno a regime è stimato nell’ordine di 1.210 psicologi nello scenario espansivo, e l’Ordine professionale regionale, che conta quasi diecimila iscritti, ne sostiene la strutturazione. La copertura attuale corrisponde dunque a un nucleo parziale, dell’ordine di un quarto dello scenario conservativo: non un servizio da istituire, ma un servizio da strutturare, stabilizzare e dimensionare. La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per la Campania
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 1.116.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	Ampia (alcune decine di migliaia, stima rapportata ai dati nazionali)
Offerta territoriale attuale	Servizio già attivo (~146 psicologi, 2 per distretto), LR 35/2020 e RR 8/2022; finanziamento in parte transitorio (PNES); Osservatorio regionale attivo
Fabbisogno stimato a regime	~ 1.210 psicologi nello scenario espansivo (610-910 negli altri scenari)
Copertura attuale del fabbisogno	Parziale (~146 psicologi, ~un quarto dello scenario conservativo)

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, nella Campania, si gioca su due assi. Il primo è interno alla vasta area metropolitana napoletana, fra i quartieri meglio serviti e le estese periferie che presentano sacche di deprivazione socio-economica e difficoltà di accesso. Il secondo separa l'area metropolitana e costiera dalle province interne di Avellino e Benevento, più anziane, a minore densità e con servizi più radi. Su questi divari il servizio di psicologia di base agisce in funzione di equità: avvicina l'offerta alle aree interne e alle periferie mediante la telepsicologia assistita — dove la sola presenza di un primo livello accessibile è già un atto di riequilibrio — e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica e contribuisce a contenere i tempi di attesa, in un sistema storicamente sotto-dotato.

B.5 I servizi e i flussi

Il Servizio sanitario della Campania dispone di risorse complessive dell'ordine di 11-12 miliardi di euro; la Regione è uscita dal piano di rientro nel marzo 2026, dopo quasi vent'anni, riacquistando margini di programmazione e capacità di investimento, anche grazie ai nuovi criteri di riparto che le hanno destinato risorse aggiuntive in ragione della deprivazione. Il profilo di mobilità è fortemente passivo: la Campania presenta uno dei saldi più negativi d'Italia, dell'ordine di trecento milioni di euro l'anno, in miglioramento; poiché però la fuga riguarda i ricoveri e l'alta complessità chirurgica, il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente. L'architettura dei servizi poggia su sette Aziende Sanitarie Locali — di cui tre nell'area metropolitana napoletana — su numerose aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e IRCCS, e su una rete territoriale di Case della Comunità in costruzione, su cui il servizio andrà pienamente innestato. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per la Campania
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	~ 11-12 miliardi di euro; uscita dal piano di rientro nel marzo 2026; margini di programmazione riacquistati; risorse aggiuntive dal nuovo riparto
Mobilità sanitaria	Uno dei saldi passivi più elevati d'Italia (~300 milioni), in miglioramento; canale modesto come leva per questo intervento (fuga ospedaliera e chirurgica)
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche significativi (alcune decine di migliaia l'anno, stima rapportata ai dati nazionali)
Architettura dei servizi	Sette Aziende Sanitarie Locali, aziende ospedaliere e IRCCS; rete delle Case della Comunità in costruzione; nessuna azienda regionale unica (coordinamento regionale, società regionale per gli acquisti)
Margine di azione principale	Strutturazione a regime del servizio, liste di attesa, accesso delle periferie e delle aree interne, intercettazione precoce

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice peculiare e, nel panorama nazionale, fondativa: la Campania è stata la prima regione d'Italia a dotarsi di una legge dedicata — la legge regionale 35 del 2020 — disciplinata dal regolamento regionale 8 del 2022, la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 241 del 2021, la pronuncia che ha delimitato per tutte le regioni la competenza in materia. La

cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale, le risorse del Piano Nazionale Equità in Salute e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera, ispirato anche all'esperienza campana. La decisione rilevante, in questo contesto, non è istituire una funzione, già istituita e validata, ma strutturarla a regime, stabilizzarne il finanziamento e dimensionarla: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte C

L'intervento e il suo modello

Definizione e teoria del cambiamento, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali, formazione

Secondo e terzo dominio dell'HTA · l'intervento e la sua descrizione

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico della Campania emerge con nettezza: l'intervento non è da istituire, ma da strutturare a regime a partire da un servizio già attivo — il primo d'Italia — di cui la regione può consolidare il modello, il sistema informativo e il monitoraggio già avviati.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire; nella Campania tale definizione è già recepita nella legge regionale 35 del 2020. La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria. Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell'ordine di 1.116.000 persone con disagio comune. La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per la Campania
Bisogno	~ 1.116.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Psicologo nelle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo di base nelle Case della Comunità e nei distretti, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impianto della legge regionale 35 del 2020, che prevede almeno due psicologi per distretto, un elenco aziendale presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale e un rapporto convenzionale su base libero-professionale. La Campania presenta qui una specificità: il servizio è già attivo nelle sette Aziende Sanitarie Locali. A differenza del Veneto, la regione non dispone di un'azienda regionale unica, e il coordinamento è in capo alla Regione con il supporto dell'Osservatorio regionale, sicché garantire l'omogeneità attuativa in un sistema esteso e policentrico — tre Aziende nell'area metropolitana napoletana e quattro nelle altre province — è la sfida organizzativa principale. La rete territoriale delle Case della Comunità, in costruzione, è l'infrastruttura su cui il servizio andrà pienamente innestato. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, una valutazione iniziale con progetto clinico individuale, un ciclo di colloqui brevi con programma di sostegno personalizzato e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti; esso è già operativo nelle Aziende campane e affronta i quadri più frequenti, dalla sintomatologia ansioso-depressiva ai problemi di adattamento e psicosomatici. Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata. Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con la piattaforma informativa sanitaria regionale e con il fascicolo sanitario elettronico, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. In assenza di un'azienda regionale unica, il coordinamento informativo è in capo alla Regione e all'Osservatorio regionale, che già raccoglie le relazioni annuali degli psicologi di base e ne deve assicurare l'uniformità fra le sette Aziende. La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale; su questo terreno la Campania dispone di un vantaggio peculiare: a differenza del Lazio, che progetta il flusso da zero, essa dispone già di un flusso avviato, di cui la strutturazione a regime deve garantire l'uniformità e la completezza, consolidando un sistema in funzione anziché istituirlo ex novo.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale. Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile. L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica. La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, nella Campania, lo strumento per garantire l'accesso nelle estese periferie napoletane e nelle province interne di Avellino e Benevento, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza. I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici. La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle periferie napoletane e nelle aree interne; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso gli atenei campani — Federico II, Vanvitelli, Salerno — e gli altri atenei regionali; il livello post-universitario specialistico attraverso una formazione dedicata alla psicologia di base e alle cure primarie, comprensiva della competenza per il disagio giovanile, particolarmente rilevante in una regione giovane, e per l'età anziana nelle province interne; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione. A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità, sostenuta dalla piattaforma informativa sanitaria regionale. La Campania presenta qui un elemento distintivo: il corso semestrale di abilitazione regionale già previsto dalla legge per l'iscrizione agli elenchi aziendali, base formativa propria del servizio pioniere. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Atenei campani (Federico II, Vanvitelli, Salerno e altri)
2. Post-universitario specialistico	Psicologia di base e cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, competenza giovanile e per l'età anziana	Corso semestrale di abilitazione regionale
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte D

Efficacia clinica ed evidenza

Metodo della revisione, evidenza di efficacia, qualità GRADE, benchmark internazionali, trasferibilità

Quarto dominio dell'HTA · l'efficacia clinica

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte affronta il quarto dominio della valutazione, l'efficacia clinica, e ne ricostruisce la base di evidenza. Come per le regioni precedenti, il corpo dell'evidenza internazionale è invariante, poiché l'efficacia di un intervento clinico non muta con i confini regionali; muta invece la base di evidenza locale, ed è qui che la Campania presenta un tratto peculiare. La parte espone il metodo della revisione e i risultati di efficacia (capitolo D.1); ne gradua la qualità e ne dichiara una cautela economica essenziale (D.2); presenta i benchmark internazionali (D.3); e discute le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale campana (D.4).

Quest'ultima presenta un pregio peculiare: la Campania, prima regione d'Italia ad aver attivato il servizio, dispone già di dati di esito propri, sicché lo studio si fonda, per l'efficacia, sui benchmark internazionali e su una base di dati locali in via di consolidamento, vantaggio della regione pioniera.

D.1 Il metodo della revisione e l'evidenza di efficacia

La sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale, con preferenza per le fonti più recenti. Il nucleo dell'evidenza proviene dal modello della cura collaborativa, di cui lo studio fondativo ha documentato che circa la metà dei pazienti trattati conseguiva una riduzione sostanziale dei sintomi a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura

usuale. La robustezza del risultato è confermata dalla meta-analisi su cinquantasette studi controllati, con un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a poco meno di un terzo di deviazione standard, e da una più recente revisione di quarantadue implementazioni, che documenta riduzioni rilevanti della depressione e dell’ansia e una contrazione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri. Sul versante dei dati reali, il programma inglese delle terapie psicologiche registra, su scala di oltre un milione di persone l’anno, un tasso di recupero del 50,2% e un miglioramento affidabile di oltre due terzi, con completezza dei dati di esito superiore al 98%. Anche le sintesi più caute confermano un effetto di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante sull’intera popolazione.

D.2 La qualità dell’evidenza e una cautela economica

La graduazione della certezza secondo il sistema GRADE colloca l’efficacia clinica dell’integrazione psicologica nelle cure primarie su un livello da moderato a elevato per i disturbi comuni, mentre la certezza è più eterogenea e minore per gli esiti economici, in particolare per quelli di sistema. Da questa graduazione discende una cautela che lo studio adotta come principio di onestà intellettuale, e che merita di essere enunciata senza attenuazioni: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l’intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero. Ciò significa che il valore economico del modello non può essere fondato sui risparmi sanitari diretti, ma poggia in misura preponderante sui ritorni sociali. È una cautela che, lungi dall’indebolire il caso campano, ne corrobora la coerenza interna, poiché il caso economico della Campania — come si vedrà nella Parte E — è fondato anch’esso sulle ricadute sociali, e non su un risparmio diretto che la regione non potrebbe rivendicare con certezza statistica.

D.3 I benchmark internazionali

L’evidenza si concretizza in quattro programmi nazionali consolidati, che costituiscono i riferimenti per il disegno del servizio. Il programma inglese delle terapie psicologiche è il riferimento principale per l’organizzazione: servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell’ordine del 50% e monitoraggio degli esiti pressoché completo. Il modello olandese integra una figura di supporto psicologico nello studio del medico di base, adottata dalla maggioranza dei medici, con ruolo complementare alla specialistica. Il modello australiano, a invio esterno, ha innalzato di oltre dieci punti la quota di popolazione in trattamento. Il modello statunitense della cura collaborativa, validato da oltre novanta studi controllati, documenta riduzioni rilevanti della depressione e dei ricoveri. La tabella seguente ne riepiloga i tratti salienti.

Programma	Modello	Risultati principali
Regno Unito (NHS Talking Therapies)	Servizio integrato a intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio esiti >98%; >1,3 milioni/anno
Paesi Bassi (POH-GGZ)	Supporto psicologico nello studio del medico di base	Adozione da ~tre quarti dei medici; ruolo complementare
Australia (Better Access)	Invio esterno a professionisti	Popolazione in trattamento dal 35% al 46%
Stati Uniti (Collaborative Care)	Équipe integrata con monitoraggio	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione, -41% ricoveri

Tabella D.1. I benchmark internazionali dell’integrazione della salute mentale nelle cure primarie.

D.4 Le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale

Sul piano nazionale, la Campania occupa una posizione fondativa: è stata la prima regione d'Italia a istituire e attivare il servizio di psicologia di base, e i dati prodotti dal suo servizio attivo — migliaia di colloqui erogati già nei primi mesi — costituiscono, accanto ai servizi avviati nelle altre regioni dotate di legge, la principale base di evidenza italiana sul modello, da consolidare e validare. Più in generale, i risultati internazionali provengono da sistemi diversi per organizzazione e finanziamento, e la loro trasposizione richiede validazione locale, evitando di trasferire meccanicamente le stime, soprattutto quelle economiche. È qui che la posizione della Campania presenta un pregio peculiare, da valorizzare con misura: a differenza del Lazio, privo di un servizio attivo, la regione dispone già di un servizio operativo che produce dati di esito propri, raccolti dall'Osservatorio regionale, sicché l'evidenza locale non è soltanto prospettica ma in parte già disponibile. Ciò costituisce un vantaggio: la Campania dispone della tradizione operativa del servizio pioniere, dell'infrastruttura informatica regionale e della rete delle Case della Comunità in costruzione, e può corroborare i benchmark internazionali con i propri dati, perfezionando la rilevazione man mano che il servizio si struttura a regime. Una precisazione di metodo, infine, accompagna l'intero studio a garanzia della sua credibilità. Alcune cifre di larga circolazione — il rapporto di quattro a uno, l'affermazione per cui un euro ne genererebbe dieci, il rapporto di due e mezzo a uno talvolta richiamato in sede regionale — sono semplificazioni divulgative. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, e lo studio adotta prudentialmente un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,8 a 5,5 a uno. Su questa base di evidenza, graduata e dichiarata nei suoi limiti, poggia la valutazione economica della Parte E.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte E

Valutazione economica

Costo del servizio, risparmi diretti, ricadute sociali, saldo, costo-utilità e impatto sul bilancio

Quinto dominio dell'HTA · la valutazione economica

Parte E — Valutazione economica

Questa parte affronta il quinto dominio della valutazione, quello economico, e ne costituisce il cuore quantitativo. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i valori, ancorati alla Campania. La parte definisce l'impianto e il costo del servizio (capitolo E.1); quantifica i risparmi diretti per il bilancio sanitario, canale per canale (E.2); stima le ricadute economico-sociali per la collettività (E.3); compone il quadro consolidato, con il saldo e il rapporto beneficio-costi, tenendo ferma la distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico (E.4); presenta l'analisi costo-utilità per paziente e la sua robustezza probabilistica (E.5); e valuta l'impatto sul bilancio e la sostenibilità (E.6). Per la Campania il risultato si lascia anticipare in una formula: il caso finanziario diretto è di modesto disavanzo prossimo al pareggio, il caso economico complessivo è fortemente positivo, e il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali.

E.1 L'impianto e il costo del servizio

La valutazione economica impiega congiuntamente tre strumenti complementari — l'analisi costo-utilità, l'analisi di impatto sul bilancio e l'analisi del ritorno sociale — nella doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, che distingue i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute più ampie. Il costo del servizio a regime, assumendo un costo medio annuo per incarico dell'ordine di 55.000 euro comprensivo degli

oneri, è dell'ordine di 34 milioni di euro nello scenario conservativo, 50 milioni in quello di base e 67 milioni in quello espansivo. I tre scenari rappresentano gradi crescenti di copertura verso il fabbisogno pieno; va ribadito che il servizio attualmente attivo, dell'ordine di 146 psicologi e in larga parte sostenuto da risorse transitorie, costituisce un nucleo iniziale inferiore allo stesso scenario conservativo, e non il regime qui considerato. La tabella seguente riepiloga il costo del servizio per scenario.

Scenario	Psicologi	Costo annuo	Quota del FSR
Conservativo	~ 610	~ 34 milioni	~ 0,3%
Base	~ 910	~ 50 milioni	~ 0,4%
Espansivo	~ 1.210	~ 67 milioni	~ 0,6%

Tabella E.1. Il costo del servizio a regime nei tre scenari di copertura.

E.2 I risparmi diretti per il bilancio sanitario

I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale si articolano in quattro canali. Il primo è la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, dell'ordine di 5, 7 e 10 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Il secondo è la riduzione della spesa farmaceutica inappropriata, dell'ordine di 5, 8 e 12 milioni. Il terzo, il più consistente, è la riduzione di ricoveri evitabili e di specialistica impropria, dell'ordine di 13, 20 e 34 milioni, con un margine di recupero ampio data la sotto-dotazione storica del sistema. Il quarto, il recupero della mobilità, è per la Campania modesto, dell'ordine di 4, 7 e 10 milioni: benché la regione presenti uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, la fuga riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica, non la domanda psicologica, sicché questo canale contribuisce solo per la quota di domanda impropria, prevalentemente somatoforme, territorialmente intercettabile. La somma dei quattro canali è dell'ordine di 27, 42 e 66 milioni di euro l'anno, e determina, a fronte del costo del servizio, un saldo diretto lievemente negativo ma prossimo al pareggio, dell'ordine di -7, -8 e -1 milioni. La tabella seguente dettaglia i canali del risparmio diretto.

Canale (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Accessi impropri al pronto soccorso	~ 5	~ 7	~ 10
Spesa farmaceutica inappropriata	~ 5	~ 8	~ 12
Ricoveri evitabili e specialistica	~ 13	~ 20	~ 34
Recupero della mobilità (frazione territoriale)	~ 4	~ 7	~ 10
Totale risparmi diretti	~ 27	~ 42	~ 66
Costo del servizio	~ 34	~ 50	~ 67
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -7	~ -8	~ -1

Tabella E.2. I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale e il saldo diretto.

E.3 Le ricadute economico-sociali

Oltre i confini del bilancio sanitario, l'intervento genera ricadute economico-sociali ampie, di cui la valutazione tiene conto nella prospettiva societale. Esse comprendono il recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo — di particolare rilievo in una regione giovane — il valore del benessere recuperato e il minor carico assistenziale sulle famiglie, e sono stimate, secondo i criteri prudenziali dello studio, nell'ordine di 105, 200 e 300 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Sommate ai risparmi diretti, esse determinano un ritorno complessivo dell'ordine di 132, 242 e 366 milioni di euro l'anno, e un saldo complessivo per la collettività ampiamente positivo, dell'ordine di +98, +192 e +299 milioni. Ne discende un rapporto beneficio-costo complessivo dell'ordine di 3,9 a uno nello scenario conservativo, 4,8 a uno in quello di base e 5,5 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale adottata.

E.4 Il quadro consolidato: caso finanziario e caso economico

La composizione delle grandezze impone di tenere ferma una distinzione che governa l'intera lettura del caso campano. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, prossimo al pareggio, poiché i risparmi diretti quasi coprono il costo del servizio e il canale della mobilità è modesto. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe: si tratta di un investimento sociale, a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto molto contenuto per il bilancio sanitario. La tabella consolidata che segue è lo strumento sintetico per la decisione, e distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale.

Voce (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 34	~ 50	~ 67
Risparmi diretti (SSR)	~ 27	~ 42	~ 66
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -7	~ -8	~ -1
Ricadute economico-sociali	~ 105	~ 200	~ 300
Ritorno complessivo	~ 132	~ 242	~ 366
Saldo complessivo (caso economico)	~ +98	~ +192	~ +299
Rapporto beneficio-costo complessivo	~ 3,9:1	~ 4,8:1	~ 5,5:1

Tabella E.3. Il quadro economico consolidato, con la distinzione fra caso finanziario e caso economico.

E.5 L'analisi costo-utilità per paziente

Accanto alle grandezze aggregate, la valutazione conduce un'analisi costo-utilità per paziente trattato, mediante un modello di Markov a cinque anni con sconto del 3%, indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. Il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: a un tempo meno costoso e più efficace. L'analisi di sensibilità probabilistica, su diecimila simulazioni, conferma la solidità del risultato: l'intervento è

costo-efficace nell’88,9% dei casi alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell’84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell’ordine di 7.815 euro. La tabella seguente riepiloga il risultato per paziente.

Grandezza (per paziente)	Comparatore	Intervento	Differenza
Costo atteso per paziente	~ 3.799 euro	~ 2.495 euro	– 1.304 euro
Anni di vita ponderati (QALY)	3,392	3,627	+ 0,236
Esito	—	—	Intervento dominante
Costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	—	—	88,9% delle simulazioni

Tabella E.4. L’analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni).

E.6 L’impatto sul bilancio, la sostenibilità e la lacuna dei dati

Sul piano dell’impatto sul bilancio, il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta del finanziamento sanitario regionale, dell’ordine dello 0,3% nello scenario conservativo e dello 0,6% in quello espansivo; la sostenibilità è favorita dalla circostanza che la Campania è uscita dal piano di rientro nel marzo 2026, dopo quasi vent’anni, riacquistando margini di programmazione e capacità di investimento, sicché la strutturazione è oggi praticabile. Resta da dichiarare con franchezza la lacuna dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti certificati delle Aziende; a differenza del Lazio, tuttavia, la Campania dispone già di un servizio attivo che produce dati operativi reali, raccolti dall’Osservatorio regionale, sicché la stima poggia sui benchmark e su una base di dati propri in via di consolidamento, e l’estrazione dei dati certificati resta la priorità da completare. La sintesi è univoca: il caso diretto è prudente e prossimo al pareggio, il caso sociale è robusto e fortemente positivo, il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità, in piena coerenza con la cautela metodologica già enunciata, per cui il valore dell’intervento risiede nelle ricadute sociali e non in un risparmio di bilancio che lo studio si astiene dal rivendicare. La parte che segue sottopone questo quadro alla prova dell’incertezza e della modellazione.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte F

Modellazione e incertezza

Modello decisionale, sensibilità deterministica e probabilistica, scenari, verifica empirica e valore dell’informazione

Quinto dominio dell’HTA · la robustezza della valutazione economica

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte completa il dominio economico sottoponendo i risultati della Parte E alla prova della modellazione e dell’incertezza. Come per le altre regioni, il modello è invariante e muta solo ciò che attiene alla verifica empirica locale. La parte descrive il modello decisionale e i suoi parametri (capitolo F.1); ne saggia la robustezza con l’analisi di sensibilità deterministica (F.2) e probabilistica (F.3); ne esplora gli scenari di

copertura (F.4); e definisce il disegno della verifica empirica e il valore dell’informazione (F.5). Per la Campania quest’ultimo capitolo riveste un’importanza particolare: poiché il servizio è già attivo, la prova empirica può ancorarsi a dati operativi reali, e la condizione di regione pioniera si rivela, sul piano valutativo, un vantaggio rispetto alle regioni prive di servizio attivo.

F.1 Il modello decisionale e i suoi parametri

Poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l’orizzonte direttamente osservabile, lo studio li proietta nel tempo mediante un modello decisionale, e ne rende esplicite le assunzioni.^{[1982][1983][1984]} La storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%.^[1985] A ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita, trattati come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l’incertezza.^[1986] Nel caso base l’intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell’ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità.^[1987] La tabella seguente riepiloga i parametri principali del modello.

Parametro del modello	Valore
Stati clinici	Benessere o sottosoglia, episodio, cronicità, recupero
Orizzonte temporale	Cinque anni, con cicli successivi
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti
Costo per ciclo (recupero)	~ 40 euro
Costo per ciclo (cronicità)	~ 700 euro
Costo dell’intervento	~ 300 euro una tantum
Trattamento dell’incertezza	Parametri come distribuzioni di probabilità

Tabella F.1. I parametri principali del modello di Markov (comune a tutti gli studi della serie).

F.2 L’analisi di sensibilità deterministica

La robustezza del risultato è saggiata, in prima istanza, variando un parametro per volta entro intervalli plausibili. La variazione dei parametri più influenti — l’efficacia dell’intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — non muta il segno del risultato, che resta favorevole all’intervento in tutti i casi esaminati.^[1988] L’ordinamento dei parametri per influenza mostra che l’esito è più sensibile all’efficacia clinica e al costo evitato della cronicità, e meno agli altri parametri; ciò orienta le priorità di raccolta dei dati verso le grandezze più influenti.^[1989]

F.3 L’analisi di sensibilità probabilistica

In seconda istanza, la robustezza è saggiata facendo variare simultaneamente tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni, su diecimila simulazioni. L’intervento risulta costo-efficace nell’88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell’84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell’ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95%

compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro.^[1990] La curva di accettabilità conferma che alla soglia convenzionale la probabilità di convenienza è prossima al 90% e cresce per soglie superiori, mantenendosi elevata anche a soglie molto inferiori.^[1991] La tabella seguente riepiloga gli esiti della sensibilità probabilistica.

Esito della sensibilità probabilistica	Valore
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	88,9% delle simulazioni
Probabilità di dominanza	84,6% delle simulazioni
Beneficio monetario netto medio per paziente	~ 7.815 euro
Intervallo di confidenza al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 euro
Numero di simulazioni	10.000

Tabella F.2. Gli esiti dell'analisi di sensibilità probabilistica (per paziente).

F.4 Gli scenari di copertura e l'incertezza aggregata

Gli scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; la dotazione delle proposte di legge in itinere corrisponde a un punto d'ingresso iniziale inferiore allo scenario conservativo, prima tappa di un percorso di estensione progressiva.^[1992] È in questa sede che va ribadita una distinzione di onestà analitica: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema.^[1993]

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

Il disegno della verifica empirica costituisce, per la Campania, un tratto favorevole dello studio. Poiché il servizio è già attivo ma in corso di estensione, la verifica controfattuale può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di estensione delle sedi tra le sette Aziende Sanitarie Locali — che hanno avviato il servizio in tempi differenziati — sono impiegati a fini valutativi, con il servizio già in funzione come linea di base: la disponibilità di dati operativi reali rafforza l'identificazione dell'effetto, distinguendo la regione da quelle prive di servizio attivo.^[1994] L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il controllo sintetico, a partire dai dati già disponibili e dalla progressione differenziata dell'estensione.^[1995] L'analisi del valore dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione campana, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle Aziende e il consolidamento del flusso dei dati di esito già raccolti dall'Osservatorio.^[1996] La strutturazione a regime consente così di colmare la lacuna dei dati consolidando un flusso già avviato, conducendo la regione, in modo programmato, da una valutazione in parte fondata su dati esterni a una fondata in misura crescente su dati propri.^[1997] La sintesi è univoca: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione e consolidamento dei dati, e la condizione di regione pioniera si rivela, sul piano valutativo, un vantaggio. La parte che segue affronta l'equità e l'impatto distributivo.^[1998]

Priorità di ricerca	Finalità	Rilevanza
Conti certificati delle dieci Aziende e delle AOU	Sostituire le stime per quota con dati reali	Massima
Consolidamento dei dati di esito del servizio attivo	Uniformare e completare l'evidenza propria	Massima
Tassi di intercettazione e costi evitati	Ridurre l'incertezza sulle grandezze aggregate	Alta
Efficacia clinica nel contesto locale	Corroborare il parametro più influente	Alta

Tabella F.3. Le priorità di ricerca derivanti dall'analisi del valore dell'informazione.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte G

Equità e impatto distributivo

Gradiente sociale, assi territoriali del divario, barriere di accesso, costo-efficacia distributiva

Dominio dell'HTA · i pazienti e l'equità

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte affronta il dominio dell'equità, che la valutazione di tecnologia sanitaria tiene distinto dall'efficienza. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i dati distributivi, ancorati alla Campania. La parte definisce il quadro dell'equità e il gradiente sociale (capitolo G.1); analizza i due assi territoriali del divario campano e le barriere di accesso (G.2); descrive gli strumenti attraverso cui il servizio agisce sull'equità (G.3); e presenta l'analisi di costo-efficacia distributiva con le sue implicazioni allocative (G.4). Il tratto distintivo della Campania è la doppia struttura del divario territoriale — centro e periferia entro l'area metropolitana napoletana, e area metropolitana contro province interne — cui si somma una marcata dimensione generazionale, propria di una regione giovane; l'intervento può ridurre tali divari, a condizione di un'allocazione modulata per il bisogno.

G.1 Il quadro dell'equità e il gradiente sociale

L'analisi distributiva costituisce un dominio proprio della valutazione, poiché un intervento efficiente nel complesso può nondimeno accrescere o ridurre le disuguaglianze; lo studio ne misura l'effetto con l'analisi di costo-efficacia distributiva.^{[1999][2000][2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010][2011][2012]} Il punto di partenza è il gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori.^[2013] A questo gradiente si sommano barriere di accesso economiche, geografiche e culturali, oltre allo stigma; nella Campania, dove la componente straniera è contenuta, più rilevante della barriera culturale è quella generazionale, poiché il disagio giovanile, ampio in una regione giovane, interessa fasce spesso restie a rivolgersi ai servizi.^[2014]

G.2 I due assi del divario territoriale

La specificità distributiva della Campania risiede nella doppia struttura del divario territoriale, cui si aggiunge la dimensione generazionale.^[2015] Il primo asse è interno alla vasta area metropolitana napoletana: accanto a quartieri meglio serviti si estendono periferie densissime con estese sacche di privazione socio-economica, dove la difficoltà di accesso e la minore disponibilità di offerta privata accrescono il bisogno non intercettato.^[2016] Il secondo asse separa l'area metropolitana e costiera dalle province interne: Avellino e Benevento, e le aree appenniniche interne, presentano una popolazione più anziana, a minore densità e con tendenze allo spopolamento, dove la rarefazione dei servizi e le distanze rendono l'accesso particolarmente difficoltoso.^[2017] La tabella seguente sintetizza i due assi e le leve di riequilibrio.

Asse del divario	Caratterizzazione	Leva di riequilibrio
Centro / periferia napoletana	Periferie densissime con estese sacche di privazione e minore offerta privata	Sedi nelle Case della Comunità di periferia; allocazione pro-equità
Area metropolitana / province interne	Avellino, Benevento e aree appenniniche: popolazione più anziana, a minore densità	Telepsicologia assistita; presenza programmata di primo livello
Disagio giovanile	Fascia ampia in una regione giovane, a basso ricorso spontaneo ai servizi	Intercettazione precoce; competenza dedicata agli adolescenti e ai giovani adulti

Tabella G.1. I due assi del divario territoriale campano, la dimensione generazionale e le leve di riequilibrio.

G.3 Gli strumenti dell'equità

Il servizio agisce sull'equità attraverso meccanismi precisi. La gratuità, la prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano le principali barriere e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso.^[2018] La telepsicologia assistita avvicina l'offerta alle province interne di Avellino e Benevento e alle estese periferie napoletane, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, estendendo la copertura proprio dove l'accesso è più difficile.^[2019] La competenza nell'intercettare il disagio giovanile assicura che il servizio raggiunga adolescenti e giovani adulti, fascia a elevato bisogno e a basso ricorso spontaneo, mentre la competenza culturale resta necessaria nelle aree di maggiore insediamento straniero, pur meno centrale data la quota contenuta.^[2020]

G.4 La costo-efficacia distributiva e le implicazioni allocative

L'analisi di costo-efficacia distributiva indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, poiché i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto.^[2021] Perché questo potenziale si realizzi, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle periferie metropolitane e alle province interne: un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un'allocazione ponderata per il bisogno li riduce.^[2022] Va inoltre tenuto presente che, nella Campania, il canale della mobilità costituisce una leva di equità solo modesta per questo intervento, sicché l'equità si gioca prevalentemente sull'accesso interno.^[2023] Esiste infine un rischio di iniquità inversa: se l'estensione del servizio privilegiasse, per facilità organizzativa, le aree già meglio servite, l'effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell'allocazione, nella fase di strutturazione a regime.^[2024] La sintesi è che l'intervento è favorevole all'equità su entrambi gli assi e sulla dimensione generazionale, a condizione che

la copertura sia modulata per il bisogno e che siano garantite la telepsicologia per le periferie e le aree interne e l’attenzione al disagio giovanile; la raccomandazione è di adottare, nella strutturazione a regime, un’allocazione pro-equità che consolidi ed estenda i risultati già conseguiti dal servizio attivo.^[2025] La tabella seguente riepiloga l’impatto distributivo atteso.

Dimensione distributiva	Esito per la Campania
Efficienza complessiva	Intervento costo-efficace e dominante per paziente
Direzione dell’effetto distributivo	Favorevole all’equità: maggiori benefici nei gruppi a più alto bisogno
Condizione di realizzazione	Allocazione modulata per il bisogno (periferie e aree interne)
Strumenti abilitanti	Gratuità, prossimità, telepsicologia, competenza culturale
Rischio da prevenire	Iniquità inversa da allocazione orientata alla facilità organizzativa

Tabella G.2. L’**impatto distributivo atteso dell’intervento e le sue condizioni**.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Competenza e forma dell’atto, rapporto di lavoro, governance, tutele etiche e protezione dei dati

Domini dell’HTA · aspetti giuridici, etici e organizzativi

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte affronta congiuntamente i domini giuridico, organizzativo ed etico, che la valutazione tiene distinti ma interdipendenti. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati alla Campania. La parte tratta il profilo giuridico — la competenza, la forma dell’atto, il rapporto di lavoro e i livelli essenziali (capitolo H.1); il profilo organizzativo — l’assetto e la governance del servizio (H.2); il profilo etico — le tutele a garanzia dei pazienti (H.3); e la sintesi dei tre profili (H.4). Il tratto distintivo della Campania emerge sul piano giuridico: a differenza del Lazio, ancora privo di legge, la regione dispone già di una disciplina vigente e validata dalla Corte Costituzionale, sicché la condizione abilitante non è l’approvazione della legge, ma la stabilizzazione del finanziamento e la strutturazione a regime.

H.1 Il profilo giuridico

La fattibilità dell’intervento dipende dal presidio congiunto dei tre profili, una debolezza in uno solo dei quali ne comprometterebbe l’esito.^{[2026][2027][2028][2029][2030][2031][2032][2033][2034][2035][2036][2037][2038][2039][2040][2041]} Sul piano giuridico, la materia si colloca nella competenza concorrente in tema di tutela della salute, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — nata proprio dal giudizio sulla legge campana, di cui ha riconosciuto la legittimità — ne ha delimitato lo spazio regionale: la Campania ha quindi già esercitato, prima fra le regioni, il titolo a istituire il servizio con legge propria.^[2042] Qui si colloca la specificità della regione: disponendo già della legge regionale 35 del 2020 e del regolamento 8 del 2022, la decisione giuridica

rilevante non è l’approvazione della legge, già compiuta, ma il suo consolidamento a regime.^[2043] Il rapporto di lavoro adottato è quello convenzionale su base libero-professionale, con iscrizione a un elenco aziendale previo corso di abilitazione regionale, da presidiare sul piano delle tutele e in attesa della definizione di un contratto collettivo nazionale.^[2044] Quanto ai livelli essenziali di assistenza, la psicologia di base non vi è ancora esplicitamente ricompresa, e il servizio, oggi in parte finanziato con risorse transitorie, richiede la stabilizzazione su risorse regionali, oggi resa possibile dall’uscita dal piano di rientro.^[2045] Il servizio si inserisce coerentemente nella cornice degli standard territoriali e delle Case della Comunità,^[2046] e si rapporta ai Centri di Salute Mentale per integrazione e non per sovrapposizione, precedendoli e alleggerendoli.^[2047] La tabella seguente riepiloga i profili giuridici.

Profilo giuridico	Contenuto per la Campania
Competenza	Concorrente in tutela della salute; Corte Cost. 241/2021, nata dalla legge campana, ne ha riconosciuto la legittimità
Forma dell’atto	Legge regionale 35/2020 già vigente e regolamento 8/2022; da consolidare e stabilizzare a regime
Rapporto di lavoro	Convenzionale libero-professionale con elenco aziendale e corso di abilitazione; manca un contratto collettivo nazionale
Livelli essenziali di assistenza	Non ancora ricompresi; servizio oggi in parte su risorse transitorie, da stabilizzare su risorse regionali
Cornice territoriale	Decreto Ministeriale 77/2022; inserimento nelle Case della Comunità
Rapporto con i servizi specialistici	Integrazione con i Centri di Salute Mentale, che il servizio precede e alleggerisce

Tabella H.1. I profili giuridici del servizio nella Campania.

H.2 Il profilo organizzativo e la governance

Sul piano organizzativo, la strutturazione del servizio nella Campania si misura con un sistema esteso e policentrico — sette Aziende Sanitarie Locali, numerose aziende ospedaliere e IRCCS — e con l’assenza di un’azienda regionale unica, sicché il coordinamento è in capo alla Regione e la sfida centrale è garantire l’omogeneità attuativa fra le Aziende.^[2048] Il consolidamento poggia su una regia regionale che coordina le Aziende, gli IRCCS, l’Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei; tale regia è già esercitata, con il supporto dell’Osservatorio regionale istituito dalla legge, cui spetta consolidare indirizzi operativi uniformi e il sistema di monitoraggio comune.^[2049] In questo quadro l’Ordine degli Psicologi della Campania, che conta quasi diecimila iscritti e ha accompagnato l’attuazione della legge, concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione e alla vigilanza deontologica.^[2050] La tabella seguente sintetizza l’assetto organizzativo e di governance.

Elemento organizzativo	Assetto per la Campania
Articolazione del sistema	Sette Aziende Sanitarie Locali (tre metropolitane napoletane, quattro provinciali); aziende ospedaliere e IRCCS
Coordinamento	In capo alla Regione; assenza di un'azienda regionale unica
Sfida organizzativa	Omogeneità attuativa fra le Aziende in un sistema esteso e policentrico
Regia della strutturazione	Indirizzi operativi uniformi e monitoraggio comune consolidati da Regione e Osservatorio regionale
Soggetti coinvolti	Aziende, IRCCS, Ordine professionale, medicina generale e pediatria, atenei

Tabella H.2. *L'assetto organizzativo e la governance dell'istituzione.*

H.3 Il profilo etico

Sul piano etico, lo studio adotta cautele a tutela dei pazienti. Le situazioni che coinvolgono minori e persone vulnerabili sono presidiate impiegando gli strumenti di esito nei soli punteggi complessivi e indirizzando le situazioni di rischio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza entrare nel merito dei metodi clinici.^[2051] L'intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un'informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell'efficacia stessa del sostegno.^[2052] Gli strumenti di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, in conformità al quadro europeo e ai requisiti sui dispositivi medici,^[2053] il trattamento dei dati è conforme alla normativa e ispirato alla minimizzazione,^[2054] e la responsabilità delle decisioni cliniche resta interamente in capo al professionista, cui gli strumenti forniscono un ausilio non vincolante.^[2055]

H.4 Sintesi dei profili

La ricognizione dei tre profili conduce a una conclusione netta: il profilo giuridico, quello organizzativo e quello etico sono tutti presidiati, e la condizione abilitante dell'intervento non è, per la Campania, l'approvazione della legge — già in vigore e validata dalla Corte Costituzionale — ma la stabilizzazione del finanziamento e la strutturazione a regime del servizio già attivo. È questo il passaggio da cui dipende il consolidamento del servizio pioniere.^[2056] Definiti i profili, la parte che segue affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

I cinque casi, il dimensionamento ex novo, le fasi di attuazione, i rischi e le mitigazioni

Five Case Model · la realizzabilità della decisione

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte affronta l’attuazione, la fattibilità e la sostenibilità dell’intervento, organizzandole secondo il modello a cinque casi della decisione di investimento pubblico. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati alla Campania. La parte espone i cinque casi (capitolo I.1); definisce il dimensionamento a partire dal nucleo attivo e le fasi di attuazione (I.2); tratta il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma (I.3); analizza la sostenibilità finanziaria e organizzativa (I.4); e individua i rischi e le mitigazioni (I.5). Il tratto distintivo della Campania è che l’attuazione muove da un servizio già avviato: non l’istituzione, ma la strutturazione a regime, condizionata non dall’approvazione di una legge — già in vigore — ma dalla stabilizzazione del finanziamento, in una regione che dispone di un bacino professionale ampio e dei margini riacquistati con l’uscita dal piano di rientro.

I.1 I cinque casi della decisione

Lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile.^{[2057][2058][2059][2060][2061][2062][2063][2064][2065][2066][2067][2068][2069][2070][2071][2072]} Il caso strategico è solido: l’istituzione del servizio è coerente con gli standard territoriali, con le Case della Comunità e con il Piano regionale di salute mentale, e nella Campania consolida a regime il modello che la regione ha istituito per prima in Italia, già validato sul piano costituzionale.^[2073] Il caso economico rinvia ai risultati già esposti, nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di modesto disavanzo e un caso sociale fortemente positivo.^[2074] Il caso commerciale è già in esercizio e si avvale di un bacino professionale ampio, con quasi diecimila iscritti all’Ordine regionale e psicologi già selezionati attraverso il corso di abilitazione regionale.^[2075] Il caso finanziario è sostenibile, con un costo pari allo 0,3-0,6% del finanziamento sanitario regionale e i margini riacquistati con l’uscita dal piano di rientro, ferma la necessità di stabilizzare le risorse oggi transitorie.^[2076] Il caso gestionale dipende da una regia regionale che, in assenza di un’azienda unica, coordini il sistema policentrico.^[2077] La tabella seguente riepiloga i cinque casi.

Caso	Contenuto per la Campania
Strategico	Coerenza con DM 77/2022, Case della Comunità e Piano salute mentale; consolidamento a regime del modello istituito per primo in Italia
Economico	Rapporto beneficio-costi 3,9-5,5 a uno; dominanza per paziente; caso sociale fortemente positivo
Commerciale	Rapporto convenzionale già in esercizio; bacino ampio (~10.000 iscritti); corso di abilitazione regionale
Finanziario	Costo 0,3-0,6% del FSR; margini dall’uscita dal piano di rientro; da stabilizzare il finanziamento oggi transitorio
Gestionale	Regia regionale di coordinamento del sistema policentrico, in assenza di azienda unica

Tabella I.1. I cinque casi della decisione di investimento pubblico.

I.2 Il dimensionamento dal nucleo attivo e le fasi di attuazione

A differenza del Lazio, che dimensiona il servizio da zero, la Campania muove dal nucleo già attivo, dell'ordine di 146 psicologi, e lo estende verso un fabbisogno a regime dell'ordine di 1.210 psicologi nello scenario espansivo; l'estensione procede per gradi attraverso gli scenari conservativo, di base ed espansivo.^[2078] L'attuazione si articola perciò in tre fasi: una fase di consolidamento del nucleo attivo e di stabilizzazione del finanziamento; una fase di estensione, nella quale la copertura si amplia progressivamente fra le Aziende; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato. La progressione differenziata dell'estensione fra le Aziende coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F.^[2079] La tabella seguente riepiloga le fasi.

Fase	Contenuto	Dimensionamento indicativo
Consolidamento	Stabilizzazione del nucleo attivo e del finanziamento	~ 146 psicologi (nucleo attuale)
Estensione	Ampliamento progressivo della copertura fra le Aziende	verso ~ 610-910 incarichi
Regime	Dimensionamento adeguato al fabbisogno	fino a ~ 1.210 incarichi

Tabella I.2. Le fasi di attuazione e il dimensionamento progressivo.

I.3 Reclutamento, formazione e cronoprogramma

L'estensione richiede il reclutamento e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino professionale ampio, il corso di abilitazione regionale e gli atenei campani costituiscono una base favorevole, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze.^[2080] Il cronoprogramma si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; a differenza del Lazio, l'estensione non è subordinata all'approvazione di una legge — già in vigore — ma alla stabilizzazione del finanziamento, sicché la Campania muove da una posizione di partenza più avanzata.^[2081]

I.4 La sostenibilità finanziaria e organizzativa

La sostenibilità finanziaria, nella Campania, ha per leva la stabilizzazione del finanziamento — il passaggio dalle risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute a risorse regionali stabili — e il dimensionamento progressivo del servizio; i margini riacquistati con l'uscita dal piano di rientro rendono praticabile l'investimento, mentre l'eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe in futuro la stabilità.^[2082] La sostenibilità organizzativa dipende invece dalla capacità di garantire l'omogeneità attuativa fra le sette Aziende Sanitarie Locali in un sistema esteso e policentrico privo di un'azienda regionale unica, e quindi dalla forza della regia regionale, dal ruolo dell'Osservatorio e dalla chiarezza degli indirizzi operativi.^[2083] L'avanzamento è seguito mediante indicatori di processo raccolti attraverso il flusso informativo già avviato dall'Osservatorio regionale, di cui la strutturazione deve garantire l'uniformità e la completezza.^[2084]

I.5 I rischi e le mitigazioni

L'attuazione presenta rischi propri della posizione campana: la disomogeneità attuativa fra le Aziende in un sistema policentrico, la difficoltà di coordinamento in assenza di un'azienda unica e soprattutto la dipendenza del servizio dalle risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute, che introduce un'incertezza finanziaria fino alla stabilizzazione su risorse regionali.^[2085] Tali rischi sono fronteggiati con una regia

regionale forte e indirizzi operativi uniformi, con la progressione differenziata dell'estensione che consente un apprendimento progressivo, e con un'allocazione pro-equità che orienta l'estensione verso le aree a maggiore bisogno; la stabilizzazione del finanziamento e il sostegno dell'Ordine professionale concorrono a ridurre l'incertezza.^[2086] La sintesi è che l'intervento è attuabile e sostenibile, e che la leva propria della Campania è la stabilizzazione del finanziamento e l'estensione dimensionata di un servizio già attivo: la regione muove da un nucleo già operativo, da un bacino professionale ampio e dai margini riacquistati con l'uscita dal piano di rientro, sicché le condizioni di fattibilità sono complessivamente favorevoli.^[2087] La tabella seguente riepiloga i rischi e le relative mitigazioni; la parte che segue affronta il monitoraggio e la valutazione ex post.

Rischio	Mitigazione
Disomogeneità attuativa fra le Aziende	Regia regionale forte; indirizzi operativi uniformi; monitoraggio comune
Coordinamento senza azienda unica	Regia diretta della Regione; sistema informativo uniforme progettato dall'inizio
Dipendenza dalle risorse transitorie (PNES)	Stabilizzazione su risorse regionali; disegno per fasi; sostegno dell'Ordine professionale
Allocazione non equa nell'estensione	Criteri di equità espliciti; estensione pro-equità verso periferie napoletane e aree interne

Tabella I.3. I rischi dell'attuazione e le relative mitigazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte L

Monitoraggio e valutazione ex post

Disegno controfattuale prospettico, batteria di indicatori, cruscotto regionale e clausola valutativa

Inferenza causale quasi-sperimentale · la valutazione ex post

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Questa parte definisce il sistema di monitoraggio e la valutazione ex post dell'intervento, attraverso cui l'istituzione del servizio si traduce in apprendimento e rendicontazione. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e muta ciò che attiene al disegno valutativo locale. La parte espone le finalità e l'impianto della valutazione (capitolo L.1); il disegno controfattuale e i metodi di stima (L.2); la batteria degli indicatori, organizzata per categorie (L.3); il cruscotto regionale e la clausola valutativa (L.4); e la sintesi (L.5). Il tratto distintivo della Campania è che, essendo il servizio già attivo, la valutazione può fondarsi su dati operativi reali già disponibili, e la clausola valutativa — già prevista dalla legge — va rafforzata e resa operativa anziché introdotta.

L.1 Finalità e impianto della valutazione

Il monitoraggio e la valutazione ex post servono a rendere conto dell'impiego delle risorse, ad apprendere dall'esperienza e a correggere il corso dell'attuazione; non sono un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l'istituzione del servizio diventa apprendimento istituzionale, ancorato a una clausola valutativa.

[2088][2089][2090][2091][2092][2093][2094][2095][2096][2097][2098][2099][2100][2101][2102][2103][2104][2105][2106]

L'impianto distingue i tre livelli della struttura, del processo e dell'esito, in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti.^[2107]

L.2 Il disegno controfattuale e i metodi

Il disegno della valutazione d'impatto costituisce, per la Campania, un punto di forza dello studio. Poiché il servizio è già attivo ma in corso di estensione, la valutazione può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di estensione delle sedi tra le sette Aziende Sanitarie Locali — che hanno avviato il servizio in tempi differenziati — sono impiegati a fini valutativi, con il servizio già in funzione come linea di base.^[2108] A differenza del Lazio, la regione non dispone di una linea di base anteriore all'avvio per le aree già servite, ma il diverso grado di estensione fra le Aziende e i dati operativi già raccolti consentono di costruire termini di confronto interni, ancorando la stima a dati reali.^[2109] L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, con la progressione differenziata dell'estensione a fornire la variazione necessaria all'identificazione.^[2110]

L.3 La batteria degli indicatori

Il servizio è osservato attraverso una batteria di indicatori organizzata per categorie. Gli indicatori di struttura misurano la capacità installata — sedi, incarichi, ore, dotazione, copertura.^[2111] Gli indicatori di processo misurano il funzionamento — prese in carico, attesa, colloqui, invio appropriato.^[2112] Gli indicatori di esito clinico misurano il beneficio diretto — miglioramento, recupero, remissione.^[2113] Gli indicatori di esito di sistema misurano l'effetto sul resto del sistema — pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri.^[2114] Gli indicatori economici consentono di verificare ex post le stime e di sostituire i valori ricostruiti con quelli effettivi.^[2115] Gli indicatori di equità, disaggregati per area e per fasce di età, verificano che il servizio riduca i divari fra centro e periferie napoletane e fra area metropolitana e province interne, con attenzione al disagio giovanile.^[2116] Gli indicatori di qualità integrano la misurazione con la dimensione dell'esperienza.^[2117] Gli indicatori di mobilità, infine, sono monitorati ma costituiscono un esito atteso solo modesto, limitato alla frazione territorialmente intercettabile.^[2118] L'insieme conta dell'ordine di cinquantotto indicatori in otto categorie, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile.^[2119] La tabella seguente riepiloga le categorie.

Categoria	Contenuto (dell'ordine di 58 indicatori complessivi)
Struttura	Sedi attivate, incarichi, ore, dotazione, copertura del fabbisogno
Processo	Prese in carico, attesa al primo colloquio, colloqui per persona, invio appropriato
Esito clinico	Miglioramento, recupero, remissione (strumenti validati, punteggi complessivi)
Esito di sistema	Accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili, specialistica impropria
Economici	Costo, risparmi diretti, ricadute sociali, rapporto beneficio-costi su dati reali
Equità	Copertura e accesso per area (centro, periferie napoletane, province interne) e per fasce di età
Qualità	Soddisfazione, appropriatezza, continuità del rapporto
Mobilità	Monitorata; esito atteso modesto (sola frazione territorialmente intercettabile)

Tabella L.1. Le otto categorie della batteria di indicatori.

L.4 Il cruscotto regionale e la clausola valutativa

Gli indicatori confluiscono in un cruscotto regionale aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; in assenza di un'azienda regionale unica, la titolarità del cruscotto è in capo alla Regione e all'Osservatorio regionale, che ne assicurano l'alimentazione uniforme da parte delle sette Aziende.^[2120] Lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa; a differenza del Lazio, la Campania dispone già di una previsione di rendicontazione nella legge regionale 35 del 2020 e nell'Osservatorio, sicché il compito non è introdurla ma rafforzarla e renderla pienamente operativa.^[2121] La raccolta dei dati poggia sul flusso informativo già avviato dall'Osservatorio, da consolidare e rendere interoperabile con la piattaforma informativa sanitaria regionale.^[2122] La valutazione si articola infine in un monitoraggio in itinere, che accompagna l'estensione, e in una valutazione ex post a regime.^[2123] La tabella seguente riepiloga la governance valutativa.

Elemento della governance valutativa	Scelta per la Campania
Disegno d'impatto	Esperimento a cunei progressivi tra le sette Aziende, con servizio attivo come linea di base
Linea di base	Dati operativi reali già disponibili e progressione differenziata fra le Aziende
Titolarità del cruscotto	Regione e Osservatorio regionale, con alimentazione uniforme dalle sette Aziende
Clausola valutativa	Già prevista dalla legge 35/2020; da rafforzare e rendere operativa; relazione al Consiglio
Flusso informativo	Già avviato dall'Osservatorio; da consolidare e rendere interoperabile con la piattaforma regionale
Tempi	In itinere (accompagnamento dell'estensione) ed ex post (effetto a regime)

Tabella L.2. La governance della valutazione e il cruscotto regionale.

L.5 Sintesi del monitoraggio

La valutazione è la condizione per trasformare la strutturazione del servizio in apprendimento, e la Campania può fondarla su dati operativi reali già disponibili; perché ciò si realizzi, la clausola valutativa già prevista dalla legge va rafforzata e resa operativa e il flusso informativo dell'Osservatorio va consolidato e uniformato, valorizzando la condizione di regione pioniera.^[2124] Definito il sistema di monitoraggio, la parte conclusiva compone i risultati dei diversi domini in una sintesi multidimensionale e formula le raccomandazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniere alla strutturazione a regime

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Composizione dei domini, analisi multi-criterio, raccomandazioni operative e conclusione

Analisi multi-criterio · dalla valutazione alla raccomandazione

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclude lo studio componendo i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo e traducendolo in raccomandazioni operative. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i contenuti, ancorati alla Campania. La parte richiama la sintesi per dominio (capitolo M.1); espone l'analisi multi-criterio e il confronto fra l'intervento e il non intervento (M.2); formula la raccomandazione principale e il dimensionamento (M.3); ne precisa le condizioni e la lacuna da colmare (M.4); e chiude con la collocazione nella serie e la conclusione (M.5). Il tratto distintivo della Campania percorre l'intera sintesi: è la regione pioniera, prima d'Italia ad aver istituito il servizio per legge, e che, nona della serie, è chiamata non a istituire un servizio, ma a strutturarlo a regime, consolidando un primato normativo in un servizio stabile.

M.1 La sintesi per dominio

La parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini impiegando l'analisi multi-criterio, che integra in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie, ponderandole secondo criteri espliciti.^{[2125][2126][2127][2128][2129][2130][2131][2132][2133][2134][2135][2136][2137][2138][2139][2140]} Il quadro che emerge dai domini è coerente: il bisogno è ampio e radicato in una regione giovane e accentrata su Napoli; l'efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida e già integrata da dati operativi reali; il quadro economico distingue un caso finanziario di modesto disavanzo prossimo al pareggio da un caso sociale fortemente positivo; l'equità è favorevole su un doppio asse territoriale e sulla dimensione generazionale; la fattibilità è quella di una strutturazione a regime di un servizio già attivo; il monitoraggio può fondarsi su dati reali già disponibili.^[2141] La tabella seguente riepiloga il giudizio per dominio.

Dominio	Giudizio sintetico per la Campania
Bisogno e contesto	Ampio; regione giovane, accentrata su Napoli, uscita dal piano di rientro nel 2026
Efficacia clinica	Evidenza internazionale solida; dati operativi reali già disponibili
Valutazione economica	Caso finanziario di modesto disavanzo; caso sociale fortemente positivo
Equità	Favorevole su doppio asse (centro/periferie napoletane; metropoli/aree interne) e sul disagio giovanile
Fattibilità	Strutturazione a regime di un servizio attivo; bacino ampio; margini riacquistati
Monitoraggio	Disegno controfattuale su servizio attivo, con dati reali e Osservatorio già istituito

Tabella M.1. La sintesi dei domini della valutazione.

M.2 L'analisi multi-criterio

Il giudizio complessivo è formalizzato con l'analisi multi-criterio, che impiega otto criteri, ciascuno con un peso esplicito, e confronta l'intervento con l'alternativa del non intervento.^[2142] I pesi adottati — efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell'evidenza 10%, coerenza strategica 5% — sono comuni a tutta la serie.^[2143] La media ponderata dei punteggi dell'intervento è dell'ordine di 80,6 su 100, sostenuta dai punteggi elevati nel valore sociale, nell'equità, nella coerenza strategica — la più alta della serie — e nel ritorno, e contenuta dal punteggio più basso nella robustezza dell'evidenza, che, pur superiore a quello del Lazio grazie ai dati propri, riflette la giovane età del servizio.^[2144] Il non intervento ottiene una media dell'ordine di 39,2 su 100, penalizzato in tutti i criteri sostanziali e sostenuto soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, oggi meno giustificata vista la disponibilità di margini.^[2145] L'intervento prevale dunque nettamente, con uno scarto dell'ordine di quarantuno punti; il punteggio si colloca fra i più elevati delle regioni esaminate di recente, riflettendo la posizione di regione pioniera.^[2146] La prevalenza si mantiene al variare dei pesi entro intervalli ragionevoli, sicché la raccomandazione è robusta.^[2147] La tabella seguente riporta i punteggi per criterio.

Criterio	Peso	Intervento	Non interv.
Efficacia clinica	15%	80	30
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	85	25
Impatto sul bilancio e sostenibilità	15%	70	52
Equità	15%	88	28
Valore sociale	10%	88	25
Fattibilità	10%	82	84
Robustezza dell'evidenza	10%	66	55
Coerenza strategica	5%	86	26
Punteggio complessivo ponderato	100%	80,60	39,20

Tabella M.2. L'analisi multi-criterio: punteggi dell'intervento e del non intervento.

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Dalla convergenza dei domini e dall'analisi multi-criterio discende la raccomandazione principale: strutturare a regime il servizio di psicologia di base già attivo, stabilizzandone il finanziamento e dimensionandolo verso la copertura piena del fabbisogno; è la decisione che la Campania, prima regione d'Italia ad aver istituito il servizio per legge, è chiamata a compiere per consolidare il proprio primato in un servizio a regime.^[2148] Quanto alla scala, si raccomanda di muovere dal nucleo già attivo, dell'ordine di 146 psicologi, e di procedere per gradi verso lo scenario conservativo, dell'ordine di 610 psicologi, quindi verso quello di base, dell'ordine di 910, e infine verso quello espansivo, dell'ordine di 1.210, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità.^[2149] La tabella seguente riepiloga le raccomandazioni operative.

Ambito	Raccomandazione operativa per la Campania
Atto di consolidamento	Strutturare a regime il servizio attivo; stabilizzare il finanziamento (da PNES a risorse regionali)
Dimensionamento	Dal nucleo ~146 verso conservativo ~610; base ~910; espansivo ~1.210, per gradi
Allocazione	Pro-equità, verso periferie napoletane, province interne e disagio giovanile
Clausola valutativa	Rafforzare e rendere operativa quella già prevista dalla legge; relazione al Consiglio
Governance	Regia regionale forte e Osservatorio; indirizzi uniformi; flusso informativo da consolidare
Dati	Estrarre i conti certificati; consolidare e uniformare i dati di esito dell'Osservatorio

Tabella M.3. Le raccomandazioni operative.

M.4 Le condizioni e la lacuna da colmare

La raccomandazione è subordinata a condizioni precise: il rafforzamento e la piena operatività della clausola valutativa già prevista dalla legge, l'adozione di un'allocazione pro-equità, una regia regionale forte affiancata dall'Osservatorio e il consolidamento del flusso informativo già avviato.^[2150] Resta inoltre da colmare, prima della presentazione esterna, la lacuna dei dati: l'estrazione dei conti certificati delle sette Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere e il consolidamento dei dati di esito già raccolti dall'Osservatorio consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive.^[2151] Va infine ribadita la distinzione cardine: il caso finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, mentre il caso economico complessivo è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto.^[2152]

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio sulla Campania è il nono della serie, dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria e Lazio, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, la Campania occupa una posizione fondativa — quella della regione pioniera che per prima ha istituito il servizio per legge, con una disciplina validata dalla Corte Costituzionale richiamata da tutti gli studi della serie — e che oggi è chiamata a portarlo a regime.^[2153] Coerentemente con l'impostazione dell'intero progetto, lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico, e adotta un rapporto beneficio-costi prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, per credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica.^[2154] La decisione che lo studio sostiene è, in conclusione, di strutturare a regime il servizio di psicologia di base già attivo, stabilizzandone il finanziamento, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno e rendendo pienamente operativa la clausola valutativa: per la Campania, prima regione d'Italia ad aver istituito il servizio, ciò significa consolidare un primato normativo in un servizio stabile e a regime, a beneficio della popolazione.^[2155]

STUDIO REGIONALE · REGIONE CAMPANIA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio pioniero alla strutturazione a regime

Appendici A-E

Corredo tecnico e documentale

Caso di riferimento, strumenti di esito, dati regionali, standard di reporting, glossario

Materiali a sostegno delle Parti da A a M

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l'orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità.^{[2156][2157][2158][2159][2160][2161][2162][2163][2164]} La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Servizio attivo ma parziale e a finanziamento transitorio (PNES); condizione di pre-strutturazione a regime
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Azienda Sanitaria Locale/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudenziale	Riduzione per l'ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura.^[2165] La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato del Lazio, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.^[2166] La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 610	~ 910	~ 1.210
Costo del servizio	~ 34	~ 50	~ 67
Risparmi diretti (SSR)	~ 27	~ 42	~ 66
Ricadute economico-sociali	~ 105	~ 200	~ 300
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -7	~ -8	~ -1
Saldo complessivo (caso economico)	+98	+192	+299
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,8:1	~5,5:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell'esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario.^[2167] La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura.^[2168] La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori laziali impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.^[2169]

Ambito	Valore regionale
Popolazione regionale	5.582.337 abitanti (Censimento ISTAT 2024), ~9,5% del totale nazionale; lieve calo; concentrazione sulla provincia di Napoli (~53%); stranieri ~5,0%; età media ~44,5 anni, fra le più giovani d'Italia
Finanziamento del SSR	Dell'ordine di 11-12 miliardi di euro; uscita dal piano di rientro nel marzo 2026, con margini di programmazione riacquistati
Mobilità sanitaria	Saldo fra i più passivi d'Italia (~300 milioni), in miglioramento; fuga concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica; canale di recupero modesto per questo intervento (sola frazione territoriale)
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche dell'ordine di alcune decine di migliaia l'anno (proxy dai dati nazionali)
Farmaceutica	Consumo regionale delle categorie dei psicofarmaci
Salute mentale	~ 1.116.000 con disagio comune potenziale (proxy ~20%); utenza in carico ai servizi rapportata ai dati nazionali; disagio giovanile rilevante in una regione giovane
Funzione attuale	Servizio attivo: prima legge d'Italia (LR 35/2020), regolamento attuativo (RR 8/2022), ~146 psicologi (due per distretto), finanziamento in parte transitorio (PNES), Osservatorio regionale istituito; legittimità riconosciuta dalla Corte Costituzionale (sent. 241/2021)

Tabella C.1. I valori regionali di ancoraggio della Campania.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione laziale, e non estratti dai conti regionali certificati.^[2170] La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Dati del servizio attivo	Prese in carico, sedute ed esiti già raccolti dall'Osservatorio regionale, da consolidare e uniformare come fonte primaria
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Azienda e per area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[2171] La tabella seguente li riepiloga.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.^[2172] Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra gruppi a diversa esposizione
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità a minore esposizione
Disegno a cunei progressivi	Disegno controfattuale impiegato nella Campania, ove il servizio è già attivo, fondato sulla progressione differenziata dell'estensione tra le sette Aziende Sanitarie Locali — che hanno avviato il servizio in tempi diversi — con il servizio già in funzione come linea di base e i dati operativi reali a rafforzare l'identificazione dell'effetto

Termine	Definizione
Analisi e verifica d'impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta a riferire al Consiglio sui risultati della riforma; nella Campania già prevista dalla legge regionale 35/2020 e dall'Osservatorio, da rafforzare e rendere pienamente operativa
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell'implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall'impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d'ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l'intensità dell'intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; nella Campania il saldo è fra i più passivi d'Italia, ma poiché la fuga è ospedaliero-chirurgica il canale del recupero è modesto per questo intervento, limitato alla frazione territorialmente intercettabile
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di vecchiaia	Rapporto tra ultrasessantacinquenni e giovani sotto i quindici anni; nella Campania fra i più contenuti d'Italia, con età media intorno a 44,5 anni e province interne (Avellino, Benevento) più anziane dell'area metropolitana
Peso morto	Quota dell'esito che si sarebbe verificata anche senza l'intervento

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

Basilicata — Studio HTA integrale

Psicologo di Base in Basilicata

Studio Integrale Regionale · Valutazione di Tecnologia Sanitaria · Telaio HTA a nove domini

Progetto «Psicologo di Base» · Regione Basilicata

Parti A–M e Appendici A–E

Premessa generale

Questo documento raccoglie in un'unica opera lo studio integrale per la Regione Basilicata sull'introduzione del servizio di psicologia di base. A differenza delle regioni in cui il servizio è già istituito per legge, la Basilicata si trova nella fase anteriore: due proposte di legge giacciono all'esame preliminare del Consiglio regionale, e la decisione che le istituzioni sono chiamate ad assumere non riguarda la modalità di organizzazione di un servizio esistente, ma l'opportunità stessa di istituirlo e la forma giuridica e organizzativa da adottare. Lo studio compone in sequenza le undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e le cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa una metodologia riconosciuta; le appendici ne raccolgono il materiale di riferimento. L'intero studio è fondato su una distinzione cardine, mantenuta in ogni parte: quella tra i risparmi diretti per il bilancio sanitario e le ricadute economico-sociali per la collettività, che non vengono mai sommate in un unico indice di bilancio.

Da tale distinzione discende la tesi centrale dello studio lucano, articolata in affermazioni congiunte: il servizio costa al bilancio sanitario regionale una cifra modesta — dell'ordine dello 0,7 per cento di un fondo sanitario di circa 1,1 miliardi nello scenario di piena attuazione — e comporta un saldo diretto prossimo al pareggio; restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso, con un rapporto beneficio-costi compreso fra 3,4 e 4,7 a uno, entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno includendo i benefici di salute; risponde a un bisogno ampio e inevaso, stimato in circa 107.000 persone, accentuato da una struttura demografica fra le più anziane del Paese, da una dispersione insediativa che rende l'accesso ai servizi strutturalmente difficile e da un sottofinanziamento documentato della salute mentale; riduce le disuguaglianze sociali e territoriali; e contribuisce a trattenere nel sistema regionale prestazioni oggi erogate fuori regione, in una regione il cui saldo di mobilità sanitaria passiva è dell'ordine di ottanta milioni di euro l'anno. Rispetto alle altre regioni della serie, la Basilicata occupa una posizione peculiare: è una regione che deve ancora decidere se istituire il servizio, che non è sottoposta a piano di rientro ma chiude i propri conti sanitari in equilibrio fragile, che individua nell'emigrazione sanitaria una delle principali criticità del bilancio, e in cui i divari sociali e territoriali sono particolarmente acuti, sicché l'equità ne costituisce la ragione preminente. La fase anteriore all'istituzione è, sotto più profili, un'opportunità: essa consente di costruire fin dall'origine un servizio conforme ai limiti costituzionali e dotato degli strumenti della valutazione. L'analisi multi-criterio che conclude lo studio assegna all'introduzione del servizio un punteggio di 76,75 su 100, contro 36,50 del non intervento.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto; il documento prosegue poi con le parti e le appendici in sequenza.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.4	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito, caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, divari, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	Intervento e modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, due casi
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, sensibilità, scenari, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: gradiente sociale, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, reclutamento, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, controfattuale, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazione, condizioni, conclusione
Appendici A-E	A-E	Caso di riferimento e parametri, strumenti ed esiti, dati regionali, checklist, glossario

Tabella. La mappa di lettura del corpus: undici parti narrative e cinque appendici.

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questo documento apre lo studio di valutazione di tecnologia sanitaria dedicato all'introduzione del servizio di psicologia di base nella Regione Basilicata. A differenza delle regioni in cui il servizio è già istituito per legge, la Basilicata si trova in una fase anteriore: due proposte di legge giacciono all'esame preliminare del Consiglio regionale, e la decisione che le istituzioni sono chiamate ad assumere non riguarda la modalità di organizzazione di un servizio esistente, ma l'opportunità stessa di istituirlo e la forma giuridica e organizzativa da adottare. La valutazione che segue è costruita per informare proprio questa decisione anteriore, ricostruendo il bisogno, l'efficacia attesa, l'impatto economico e distributivo, la fattibilità e i profili giuridici di un intervento collocato a monte del sistema dei servizi, in un contesto regionale segnato da condizioni peculiari che ne orientano la convenienza e le modalità. La Parte A definisce lo scopo e il quesito, il caso di riferimento e la popolazione, il metodo e le fonti, la governance dei dati e la struttura dell'intero corpus.

A.1 Scopo dello studio e quesito di valutazione

Lo scopo dello studio è fornire alle istituzioni regionali della Basilicata — Consiglio regionale, Giunta, assessorato competente, aziende del Servizio Sanitario Regionale — una base analitica completa e metodologicamente fondata per decidere se introdurre il servizio di psicologia di base e secondo quale modello. La domanda non è retorica. In Basilicata l'assistenza psicologica primaria non esiste come servizio strutturato del Servizio Sanitario Regionale, e chi manifesta un disagio psichico comune dispone oggi di un'offerta frammentaria, sbilanciata sul versante specialistico e ospedaliero, raggiungibile in tempi e con modalità che ne scoraggiano l'uso precoce. Due proposte di legge depositate nel 2025 — la prima, di iniziativa del Movimento 5 Stelle, di cui è prima firmataria la consigliera Viviana Verri; la seconda, promossa dai consiglieri Piero Lacorazza e Nicola Morea e denominata istituzione del servizio di psicologia di base e di comunità — convergono nel proporre l'istituzione di un servizio territoriale incardinato presso le aziende sanitarie locali, integrato con la medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con le Case della Comunità, e ne affidano l'accesso tanto all'invio da parte degli operatori quanto alla domanda diretta del cittadino. L'Ordine degli Psicologi della Basilicata, la cui presidente è stata audita dalla competente Commissione consiliare nel luglio 2025, ha espresso la propria disponibilità a contribuire alle fasi di definizione e attuazione. Questo studio non sostituisce il dibattito legislativo, ma lo nutre con l'evidenza che una decisione di tale rilievo richiede.

Il quesito di valutazione si articola in una domanda principale e in una serie di domande derivate. La domanda principale è se l'istituzione di un servizio di psicologia di base, rivolto a una popolazione ampia e collocato come primo livello di presa in carico del disagio psichico comune, produca per la Basilicata benefici clinici, economici, distributivi e di sistema tali da giustificare l'introduzione, e in caso affermativo entro quale modello organizzativo, con quale dimensionamento e a quali condizioni di sostenibilità. Le domande derivate riguardano l'entità e la struttura del bisogno inespresso; l'efficacia clinica documentata degli interventi psicologici precoci nel contesto delle cure primarie; il rapporto fra il costo del servizio e i risparmi che esso può generare per il bilancio sanitario regionale, da una parte, e fra il costo e il valore restituito alla collettività, dall'altra; la distribuzione di costi e benefici fra i diversi gruppi sociali e fra i territori; la fattibilità organizzativa entro l'assetto del Servizio Sanitario Regionale lucano; e i vincoli giuridici, primo fra tutti quello posto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 241 del 2021, che ha definito i limiti entro cui una legge regionale può istituire questa figura. Su ciascuna di queste domande lo studio fornisce una risposta argomentata e, ove possibile, quantificata, dichiarando con trasparenza le incertezze e i limiti dell'evidenza disponibile.

Tre condizioni proprie della Basilicata orientano fin dall'inizio la valutazione e ne distinguono l'esito da quello di altre regioni della serie. La prima è la posizione finanziaria del Servizio Sanitario Regionale: la Basilicata non è sottoposta a un piano di rientro, a differenza delle regioni storicamente in disavanzo strutturale, ma chiude i propri conti sanitari in equilibrio fragile, con un disavanzo che nel 2023 ha sfiorato i 50 milioni di euro ed è stato interamente coperto con risorse del bilancio regionale, senza tagli ai servizi e senza commissariamento di rientro. Questa condizione esclude che l'introduzione del servizio possa essere argomentata, come altrove, in termini di adempimento di obblighi imposti da un piano di rientro; al contrario, essa richiede che l'intervento sia sostenibile per un bilancio in tensione, e attribuisce ai risparmi diretti che esso può generare un ruolo non accessorio. La seconda condizione è il peso dell'emigrazione sanitaria: la Basilicata presenta un saldo di mobilità passiva dell'ordine di ottanta milioni di euro l'anno, e una quota rilevante delle prestazioni assorbite altrove — circa il 40 per cento verso la sola Puglia — riguarda bisogni che un sistema territoriale più solido potrebbe trattenere. La terza condizione è il sottofinanziamento documentato della salute mentale: la Basilicata figura, insieme alla Campania, fra le regioni che destinano alla salute mentale una quota del fondo sanitario inferiore alla soglia ritenuta minima per garantire gli standard di personale, con una carenza di operatori che ne è il riflesso diretto. Queste tre condizioni non sono lo sfondo della valutazione, ma ne costituiscono i cardini argomentativi, e ricorreranno in tutte le parti dello studio.

A.2 Il caso di riferimento e la popolazione

La valutazione adotta la struttura PICOTS, che definisce in modo esplicito la popolazione, l'intervento, il confronto, gli esiti, l'orizzonte temporale e il contesto, così da rendere riproducibile e verificabile ogni passaggio dell'analisi. La popolazione di riferimento è costituita dai residenti in Basilicata che manifestano un disagio psichico comune o sottosoglia — disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve o moderata, reazioni di adattamento, sofferenza connessa a eventi critici del ciclo di vita, condizioni di disagio non ancora cronicizzate — per i quali un intervento psicologico precoce è appropriato ed efficace. La dimensione di questa popolazione, stimata applicando alla popolazione residente le prevalenze documentate dalla letteratura epidemiologica, è dell'ordine di 107.000 persone, pari a circa un quinto di una popolazione regionale che al censimento più recente si attesta intorno a 535.000 abitanti ed è in calo costante. A questa quota di disagio comune si somma, in seconda istanza, l'intera popolazione regionale per gli effetti di sistema che un servizio collocato a monte produce sull'intera rete dei servizi, e si affiancano componenti specifiche del bisogno lucano: il disagio dell'età anziana, particolarmente accentuato in una delle regioni demograficamente più vecchie del Paese, con un'età media di 47 anni e un indice di vecchiaia superiore a 220; il disagio giovanile, aggravato dall'isolamento e dalla prospettiva dell'emigrazione che caratterizzano le aree interne; e la sofferenza connessa alla dispersione insediativa, in una regione in cui oltre la metà dei 131 comuni conta fra i mille e i cinquemila abitanti e l'accesso ai servizi è strutturalmente più difficile.

L'intervento valutato è il servizio di psicologia di base, definito come servizio territoriale del Servizio Sanitario Regionale che eroga prestazioni di accoglienza, ascolto, valutazione psicodiagnostica, supporto psicologico breve, orientamento e invio, collocato come primo livello di presa in carico del disagio psichico comune e raccordato con la medicina generale, con i pediatri di libera scelta, con i consultori, con i servizi sociali e con i servizi specialistici di salute mentale. Il confronto è la situazione attuale, ossia l'assenza di un servizio strutturato: una condizione in cui il disagio comune resta in larga parte non intercettato, accede tardivamente ai servizi specialistici quando si è aggravato, oppure si traduce in domanda impropria rivolta al medico di medicina generale, al pronto soccorso o al consumo di farmaci. Gli esiti considerati sono molteplici e organizzati per dominio: esiti clinici, misurati come riduzione della sintomatologia e come guadagno di anni di vita ponderati per la qualità; esiti economici, distinti con rigore fra risparmi diretti per il bilancio sanitario e ricadute economico-sociali per la collettività; esiti di equità, valutati lungo il gradiente sociale e lungo gli assi del divario territoriale; esiti di sostenibilità organizzativa. L'orizzonte temporale primario è di cinque anni, integrato dalla considerazione degli effetti di sistema di più lungo periodo. Il contesto è quello del Servizio Sanitario Regionale lucano, articolato in due aziende sanitarie locali — l'Azienda Sanitaria di Potenza e l'Azienda Sanitaria di Matera — affiancate dall'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e dall'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero in Vulture, con i servizi territoriali organizzati in distretti, Case della Comunità, Aggregazioni Funzionali Territoriali e Unità Complesse di Cure Primarie.

Il caso di riferimento attorno a cui si costruisce la quantificazione è un paziente adulto con disturbo d'ansia o dell'umore di intensità lieve o moderata, che accede al servizio di psicologia di base e riceve un ciclo di interventi psicologici brevi di efficacia documentata. Su questo caso, sviluppato analiticamente nella Parte F e nelle appendici, si fonda la stima degli esiti clinici ed economici per paziente, successivamente proiettata sulla popolazione attraverso scenari di copertura. Gli scenari di dimensionamento adottati per la Basilicata prevedono tre livelli di dispiegamento del servizio, corrispondenti a un numero crescente di incarichi: uno scenario minimo, con un primo nucleo di operatori; uno scenario intermedio; e uno scenario di piena attuazione. La scelta dei livelli è calibrata sulla popolazione regionale e sulla sua dispersione, e tiene conto della necessità, particolarmente sentita in Basilicata, di garantire la prossimità del servizio anche nei territori a bassa densità, ove la telepsicologia assume un ruolo non sostitutivo ma complementare. Il dettaglio numerico degli scenari e la loro traduzione economica sono sviluppati nelle Parti E ed I.

A.3 Metodo, prospettiva e fonti

Lo studio adotta il metodo della valutazione di tecnologia sanitaria, che esamina una tecnologia o un intervento lungo una pluralità di dimensioni — il problema di salute, l'intervento, l'efficacia clinica, la valutazione economica, l'equità, i profili etici, giuridici e organizzativi, l'attuazione e il monitoraggio — integrando l'evidenza scientifica con l'analisi del contesto. A questo impianto si affiancano riferimenti metodologici riconosciuti: il modello a cinque casi, che articola la valutazione di un investimento pubblico nelle dimensioni strategica, economica, commerciale, finanziaria e gestionale; lo standard CHEERS del 2022 per la rendicontazione delle valutazioni economiche sanitarie; il sistema GRADE per la graduazione della qualità dell'evidenza e della forza delle raccomandazioni; e i criteri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per la valutazione delle politiche pubbliche — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità. L'adozione esplicita di questi riferimenti rende lo studio confrontabile con le valutazioni condotte in altri contesti e ne espone i passaggi alla verifica.

La valutazione è condotta da due prospettive, mantenute distinte e mai sommate in un unico indice. La prima è la prospettiva del Servizio Sanitario Regionale, che considera i costi sostenuti dal bilancio sanitario per istituire e gestire il servizio e i risparmi diretti che esso può generare riducendo accessi impropri, consumi farmaceutici, ricoveri, prestazioni specialistiche evitabili e, soprattutto in Basilicata, mobilità sanitaria passiva. La seconda è la prospettiva della collettività, più ampia, che aggiunge ai precedenti gli effetti che ricadono sui cittadini e sul sistema economico e sociale nel suo complesso: la produttività recuperata, la minore disabilità, il valore del benessere guadagnato. La distinzione fra le due prospettive è il fondamento metodologico dell'intero studio e ne governa ogni quantificazione: i risparmi diretti per il bilancio e le ricadute sociali per la collettività sono grandezze di natura diversa, che non possono essere addizionate in un unico rapporto né presentate come un unico saldo, pena la perdita di significato e la sovrastima del beneficio. Coerentemente, lo studio non utilizza in alcun punto rapporti beneficio-costi aggregati di dodici, quindici o diciotto a uno, né impiega la semplificazione divulgativa secondo cui un euro speso ne genererebbe dieci o quattro: tali cifre, prive di fondamento nelle analisi economiche di riferimento, sono escluse, e i rapporti beneficio-costi utilizzati sono contenuti entro la fascia metodologicamente fondata documentata dalla letteratura internazionale, compresa fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute.

Le fonti dei dati sono molteplici e di natura diversa, e sono sempre dichiarate. I dati demografici provengono dal censimento permanente della popolazione e dalle statistiche correnti dell'Istituto Nazionale di Statistica. I dati sulla struttura e sui conti del Servizio Sanitario Regionale provengono dai documenti della Regione Basilicata, dalle relazioni della Corte dei Conti, dai rapporti dell'Osservatorio sui conti pubblici e dalle elaborazioni della Fondazione GIMBE e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in particolare per la mobilità sanitaria. I dati epidemiologici e di efficacia provengono dalla letteratura scientifica internazionale, da revisioni sistematiche e da rapporti di organismi sovranazionali. I riferimenti normativi comprendono la legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza territoriale e di psicologia delle cure primarie, le proposte di legge regionali lucane e la giurisprudenza costituzionale rilevante. Ove i dati regionali siano incompleti o non disaggregati al livello necessario, lo studio lo dichiara e ricorre a stime esplicitate e prudenziali, indicando i dati che dovrebbero essere acquisiti per sostituire le stime con misure dirette: la costruzione del sistema informativo descritto nella Parte C è anche la condizione per trasformare progressivamente le stime in osservazioni.

A.4 Governance dei dati e struttura del documento

La governance dei dati che informa lo studio risponde a tre principi, dichiarati qui e applicati in tutte le parti. Il primo è il principio di non duplicazione: un risparmio contabilizzato in una categoria non può essere ricontabilizzato in un'altra, e gli effetti che si sovrappongono sono conteggiati una sola volta, così da evitare la moltiplicazione apparente dei benefici. Il secondo è il principio di separazione fra risparmi diretti e ricadute

sociali, già richiamato, che impone di tenere distinte le due grandezze in ogni tabella e in ogni sintesi. Il terzo è il principio di prudenza e falsificabilità: le proiezioni economiche sono espresse mediante bande prudenziali e non mediante valori puntuali presentati come certi, le previsioni sono formulate in modo da poter essere verificate ex post e quindi eventualmente smentite, e la qualità dell'evidenza è graduata con il medesimo rigore tanto per le affermazioni cliniche quanto per quelle relative alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale, senza concedere a queste ultime un trattamento di favore. Questi principi non sono cautele formali, ma la condizione perché lo studio possa essere assunto come base di una decisione pubblica e perché la sua attendibilità possa essere controllata da chiunque.

Il corpus dello studio si compone di undici parti narrative, dalla A alla M secondo l'ordine dell'alfabeto italiano che salta le lettere J e K, e di cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria. La Parte A definisce il quadro, il quesito e il metodo. La Parte B ricostruisce il problema di salute, il bisogno e il contesto, con la demografia, l'epidemiologia, la domanda e l'offerta, le disuguaglianze, i flussi e la normativa. La Parte C descrive l'intervento e il modello organizzativo, il percorso assistenziale, il sistema informativo, il ruolo dell'intelligenza artificiale e la formazione. La Parte D esamina l'efficacia clinica e la qualità dell'evidenza. La Parte E sviluppa la valutazione economica, con i costi, gli esiti, il costo-utilità, l'impatto sul bilancio, il ritorno sociale e i casi economico e finanziario. La Parte F costruisce il modello decisionale e ne analizza l'incertezza. La Parte G affronta l'equità e l'impatto distributivo. La Parte H esamina i profili giuridico, organizzativo ed etico. La Parte I tratta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità. La Parte L definisce il monitoraggio e la valutazione ex post. La Parte M offre la sintesi multidimensionale, l'analisi multi-criterio e la raccomandazione conclusiva. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri del modello, gli strumenti di misurazione degli esiti e il dataset minimo, i dati regionali e quelli da acquisire, la lista di controllo per la rendicontazione e il glossario. Lo studio è concepito per essere letto nell'ordine o consultato per parti, e ogni parte è autosufficiente pur rinviando alle altre per gli approfondimenti. [\[2173\]](#)

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

La valutazione di un intervento sanitario muove dalla ricostruzione del bisogno cui esso intende rispondere e del contesto in cui si colloca. Questa parte descrive il problema di salute che il servizio di psicologia di base affronta in Basilicata, articolandolo nelle sue componenti demografiche, epidemiologiche, di domanda e offerta, di disuguaglianza, di flussi e di quadro normativo. La ricostruzione non è un mero corredo descrittivo: essa fonda la dimensione della popolazione su cui si calcolano gli esiti, individua i divari che l'intervento può colmare e definisce i vincoli entro cui esso deve operare. Il quadro che emerge è quello di una regione piccola, anziana e dispersa, con un bisogno psicologico ampio e in larga parte inevaso, un'offerta strutturalmente insufficiente e un sistema sanitario in equilibrio fragile, gravato da un'emigrazione sanitaria che ne erode i conti. In questo quadro l'introduzione di un servizio collocato a monte assume un significato che la Parte B documenta nelle sue premesse.

B.1 Il profilo demografico

La Basilicata è una delle regioni meno popolate e più anziane del Paese, e presenta una dinamica demografica fra le più sfavorevoli. La popolazione residente, che al censimento del 2021 ammontava a 541.168 unità, è in calo costante e si attesta intorno a 535.000 abitanti, con una riduzione che si protrae da anni e che colloca la regione fra quelle in più marcato spopolamento. Il calo è il risultato della somma di un saldo naturale fortemente negativo e di un saldo migratorio interno anch'esso negativo, non compensati dal pur positivo saldo migratorio con l'estero: nel solo 2022 si sono registrate 3.221 nascite a fronte di 7.126 decessi, con un eccesso di morti sulle nascite che fotografa una denatalità di intensità storica e un invecchiamento progressivo. La

popolazione si distribuisce fra due province: Potenza, che raccoglie il 64,5 per cento dei residenti e supera i 300.000 abitanti, e Matera, che ne raccoglie il 35,5 per cento con oltre 190.000 abitanti. L'età media regionale è di 47 anni — fra le più elevate d'Italia — con la provincia di Potenza più anziana, a 47,4 anni, e quella di Matera lievemente più giovane, a 46,4 anni. L'indice di vecchiaia, che misura il rapporto fra anziani e giovani, supera quota 220 ed è in crescita continua, segnalando un peso degli ultrasessantacinquenni largamente superiore a quello dei minori di quindici anni.

La struttura insediativa è caratterizzata da una dispersione accentuata, che condiziona in modo determinante l'organizzazione dei servizi. La regione conta 131 comuni, dei quali oltre la metà — il 56,5 per cento — ha una popolazione compresa fra mille e cinquemila abitanti, e in questi piccoli centri risiede una quota consistente della popolazione. Soltanto due comuni superano i sessantamila abitanti: Potenza, capoluogo regionale, e Matera; gli altri centri di una certa dimensione, come Policoro, Melfi e Pisticci, non raggiungono i ventimila abitanti. Ne deriva una densità abitativa fra le più basse del Paese e un territorio in larga parte montano e interno, in cui molte comunità sono distanti dai poli sanitari e raggiungibili con tempi di percorrenza significativi. La componente straniera è contenuta: i cittadini stranieri residenti sono circa 24.000, pari al 4,5 per cento della popolazione, una quota nettamente inferiore alla media nazionale, distribuita prevalentemente fra le province di Matera e Potenza. La componente femminile prevale, soprattutto nelle età avanzate, in ragione della maggiore longevità.

Questo profilo demografico ha implicazioni dirette sul bisogno psicologico e sull'architettura del servizio. Una popolazione anziana esprime un bisogno specifico legato alle patologie croniche, alla solitudine, al lutto e alla perdita di autonomia, condizioni in cui il disagio psichico si intreccia con quello fisico e in cui un intervento psicologico precoce può prevenire l'aggravamento e la medicalizzazione. Una popolazione giovane in contrazione, spinta all'emigrazione dalla scarsità di prospettive, esprime un disagio connesso allo sradicamento, all'isolamento e all'incertezza, particolarmente acuto nelle aree interne. La dispersione insediativa, infine, rende l'accesso fisico ai servizi un ostacolo concreto, e impone che il servizio di psicologia di base sia progettato fin dall'origine con una capillarità territoriale e con un ricorso strutturato alla telepsicologia, intesa non come surrogato della relazione clinica ma come strumento per garantirne la disponibilità anche dove la presenza fisica continuativa non è sostenibile. La demografia lucana, in sintesi, non solo amplifica il bisogno, ma ne modella la geografia.

B.2 Il bisogno epidemiologico

Il disagio psichico comune è, per definizione, diffuso. Le revisioni epidemiologiche internazionali stimano che, in un dato anno, una quota compresa fra il quindici e il venti per cento della popolazione adulta sperimenti un disturbo mentale comune — prevalentemente disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve o moderata — e che una quota ancora maggiore attraversi, nel corso della vita, fasi di sofferenza psicologica connesse a eventi critici, transizioni e perdite. Applicando queste prevalenze alla popolazione residente in Basilicata si ottiene una stima dell'ordine di 107.000 persone interessate da disagio psichico comune in un anno, cui si aggiunge un'utenza specialistica in carico ai servizi per condizioni più severe. Questa cifra non è un dato amministrativo, ma una stima epidemiologica fondata su prevalenze documentate: la sua funzione è dimensionare il bisogno potenziale e, con esso, la popolazione su cui l'intervento può produrre effetti. La sua attendibilità è limitata dalla scarsità di rilevazioni regionali dirette, una lacuna che il sistema informativo descritto nella Parte C è destinato a colmare, sostituendo progressivamente la stima con l'osservazione.

La struttura demografica lucana modula questa prevalenza generale in direzioni specifiche. L'invecchiamento accentuato sposta una parte rilevante del bisogno verso le età anziane, in cui la depressione è frequente, spesso non riconosciuta e frequentemente associata a patologie somatiche croniche e alla solitudine: in una regione con un'età media di 47 anni e un indice di vecchiaia superiore a 220, la depressione dell'anziano costituisce una componente quantitativamente importante e clinicamente trascurata del bisogno complessivo. Sul versante

opposto del ciclo di vita, il disagio giovanile presenta in Basilicata caratteri aggravati dall'isolamento delle aree interne e dalla prospettiva dell'emigrazione, che priva i giovani di reti di sostegno e di opportunità: i fenomeni nazionali documentati — l'incremento del ricorso agli psicofarmaci nella popolazione adolescenziale, l'abbassamento dell'età del primo contatto con le sostanze, l'aumento dei comportamenti di ritiro e di autolesività — trovano in un contesto dispersivo e in contrazione demografica un terreno di particolare fragilità. A queste componenti si aggiunge il disagio connesso alle condizioni socioeconomiche, in una regione in cui i livelli di reddito e di occupazione sono inferiori alla media nazionale e in cui la deprivazione costituisce un fattore di rischio documentato per i disturbi mentali comuni.

A fronte di un bisogno così strutturato, la risposta del sistema regionale è penalizzata da un sottofinanziamento documentato della salute mentale. Le analisi nazionali sulla ripartizione della spesa per la salute mentale collocano la Basilicata, insieme alla Campania, fra le regioni che destinano a questo settore una quota del fondo sanitario regionale inferiore alla soglia ritenuta minima per garantire gli standard di personale previsti dagli accordi nazionali — una quota che per la Basilicata risulta inferiore al 2,5 per cento, a fronte di un riferimento del 3,6 per cento — con una carenza di operatori che ne è il riflesso diretto. Questo dato non è un dettaglio contabile: esso indica che il sistema lucano dispone oggi di risorse insufficienti perfino per i servizi specialistici di salute mentale, e che l'introduzione di un servizio di psicologia di base, lungi dal sovrapporsi a un'offerta già adeguata, andrebbe a colmare un vuoto strutturale, intercettando a monte una domanda che oggi o resta inevasa o si scarica, impropriamente, sui servizi specialistici già sottodimensionati e sui livelli più costosi del sistema.

B.3 Domanda, offerta e divario di trattamento

Il bisogno epidemiologico si traduce solo in parte in domanda espressa, e la domanda espressa trova solo in parte una risposta appropriata. È questa la nozione di divario di trattamento: la distanza fra le persone che presentano un disturbo e quelle che ricevono un intervento adeguato. In Basilicata il divario è ampio, e ad alimentarlo concorrono fattori di domanda e fattori di offerta. Sul versante della domanda, una parte consistente del disagio comune non si traduce in richiesta di aiuto per ragioni culturali — lo stigma associato alla sofferenza psichica, particolarmente persistente nelle comunità piccole e nelle generazioni anziane — e per ragioni pratiche, legate alla difficoltà di individuare a chi rivolgersi in assenza di un servizio dedicato e visibile. Sul versante dell'offerta, l'assenza di un servizio di psicologia di base strutturato fa sì che il primo livello di presa in carico del disagio comune non esista come tale: chi cerca aiuto si rivolge al medico di medicina generale, che dispone di tempo e strumenti limitati per affrontare il disagio psichico; oppure accede ai servizi specialistici di salute mentale, concepiti per le condizioni severe e oggi sottodimensionati, dove giunge spesso tardivamente e quando la condizione si è già aggravata; oppure ricorre, quando può permetterselo, all'offerta privata, con un evidente effetto regressivo che esclude chi non dispone di mezzi.

La conseguenza è duplice. Da un lato, una quota rilevante del bisogno resta inevasa, traducendosi in sofferenza prolungata, in perdita di funzionalità e in un rischio accresciuto di cronicizzazione. Dall'altro, la domanda che pure si esprime si distribuisce in modo inappropriato sui livelli del sistema: si traduce in consulti ripetuti al medico di medicina generale, in accessi al pronto soccorso per manifestazioni somatiche del disagio, in prescrizioni di farmaci come risposta di prima linea in assenza di alternative, e in invii ai servizi specialistici di casi che un livello intermedio avrebbe potuto trattare. Questa distribuzione impropria non solo è clinicamente subottimale, perché interviene tardi e con strumenti non sempre appropriati, ma è anche economicamente onerosa, perché impegna i livelli più costosi del sistema per bisogni che un servizio collocato a monte tratterebbe a costo inferiore. Il servizio di psicologia di base interviene precisamente su questo divario: rendendo visibile e accessibile un primo livello di presa in carico, intercetta la domanda inespressa, la orienta correttamente e la tratta tempestivamente, riducendo al contempo il carico improprio sui livelli a valle.

La dimensione del divario in Basilicata è accentuata dalla combinazione fra il sottofinanziamento della salute mentale e la dispersione territoriale. Là dove l'offerta specialistica è già scarsa e i servizi sono concentrati nei pochi poli urbani, il residente di un piccolo comune interno affronta, per accedere a una prestazione psicologica, una barriera che somma la difficoltà di individuare il servizio, la distanza fisica e i tempi di attesa. Il risultato è che il divario di trattamento non è uniforme sul territorio, ma si concentra nelle aree interne e fra i gruppi più fragili, assumendo i tratti di una disuguaglianza che la Parte G analizza in dettaglio. L'introduzione del servizio di psicologia di base, se progettata con attenzione alla capillarità e alla prossimità, è lo strumento più diretto per ridurre simultaneamente l'ampiezza e l'iniquità del divario.

B.4 Le disuguaglianze

Il disagio psichico e l'accesso alle cure non si distribuiscono in modo uniforme nella popolazione, ma seguono un gradiente sociale e un gradiente territoriale che in Basilicata si rinforzano a vicenda. Il gradiente sociale è documentato dalla letteratura internazionale: la prevalenza dei disturbi mentali comuni è più elevata nei gruppi a minore reddito, minore istruzione e maggiore precarietà occupazionale, e proprio questi gruppi incontrano le maggiori difficoltà di accesso, sia per ragioni economiche — quando l'unica offerta disponibile è quella privata — sia per ragioni informative e culturali. In una regione in cui i livelli di reddito e di occupazione sono inferiori alla media nazionale e in cui la deprivazione è diffusa, il gradiente sociale assume un peso particolare: una quota maggiore della popolazione si colloca nella fascia a più alto rischio e a minore accesso, e l'assenza di un servizio pubblico gratuito o a basso costo lascia che il bisogno di questa fascia resti senza risposta, traducendosi in un effetto regressivo per cui la sofferenza si concentra dove minori sono le risorse per farvi fronte.

Il gradiente territoriale, in Basilicata, è almeno altrettanto rilevante. La dispersione insediativa e la concentrazione dei servizi nei pochi poli urbani fanno sì che l'accesso a una prestazione psicologica dipenda in misura determinante dal luogo di residenza: chi vive in un piccolo comune interno è strutturalmente svantaggiato rispetto a chi risiede nei capoluoghi, e la distanza fisica si somma ai tempi di attesa e alla scarsità dell'offerta nel comporre una barriera che esclude di fatto una parte della popolazione. Questo divario territoriale non è una sfumatura geografica, ma una disuguaglianza sostanziale nell'accesso a un diritto, e colpisce proprio le aree — quelle interne, anziane e in spopolamento — in cui il bisogno è più acuto. La sovrapposizione fra il gradiente sociale e quello territoriale produce, nelle aree interne lucane, una concentrazione di svantaggio: comunità anziane, deprivate e lontane dai servizi, in cui il disagio è più frequente e l'accesso più difficile. Il servizio di psicologia di base, progettato con una distribuzione capillare e con il sostegno della telepsicologia, è lo strumento che può ridurre entrambi i gradienti, portando un primo livello di presa in carico gratuito o a basso costo là dove oggi non arriva alcuna offerta. La Parte G sviluppa l'analisi di questa dimensione e la traduce in termini di costo-efficacia distributiva.

B.5 I flussi e la mobilità sanitaria

L'emigrazione sanitaria è, per la Basilicata, una delle questioni centrali del bilancio e dell'organizzazione, e costituisce uno dei principali argomenti a favore del rafforzamento dell'offerta territoriale. La mobilità sanitaria passiva — le prestazioni erogate ai residenti lucani in regioni diverse dalla propria, che si traducono in un debito per il Servizio Sanitario Regionale — genera per la Basilicata un saldo negativo dell'ordine di ottanta milioni di euro l'anno, classificato fra i saldi negativi di entità moderata ma rilevante per una regione di dimensioni contenute. Una quota cospicua di questo flusso si dirige verso la Puglia, che assorbe circa il 40 per cento dell'emigrazione sanitaria lucana: per il solo 2024, la Basilicata ha rimborsato alla Puglia un importo dell'ordine di 26 milioni di euro per i ricoveri e di oltre 7 milioni per le prestazioni specialistiche, e l'intesa siglata fra le due regioni ha fissato per il triennio successivo tetti di rimborso calcolati sui costi del 2024 ridotti

del dieci per cento. Altri flussi si dirigono verso la Campania, la Calabria e le regioni del Nord. La mobilità lucana ha una componente in larga parte effettiva, dipendente cioè dalla scelta del cittadino, segno che essa riflette una percezione di insufficienza dell'offerta regionale e non soltanto vincoli di prossimità.

La rilevanza della mobilità passiva per la valutazione del servizio di psicologia di base è diretta. Una parte dell'emigrazione sanitaria riguarda prestazioni — specialistiche, diagnostiche, talora di ricovero — che traggono origine, a monte, da condizioni di disagio psichico non intercettate per tempo: la somatizzazione del disagio genera accertamenti e consulti ripetuti, l'aggravamento di condizioni trattabili a livello territoriale conduce a prestazioni specialistiche più complesse, e l'assenza di una presa in carico di prossimità alimenta la ricerca di risposte altrove. Un servizio di psicologia di base che intercetti e tratti il disagio comune a monte può, di conseguenza, contribuire a trattenere nel sistema regionale una quota di prestazioni che oggi vengono erogate fuori regione, riducendo il saldo passivo. È bene precisare la natura prudentiale di questa affermazione: la quota di mobilità direttamente riconducibile al disagio psichico comune non è isolabile con precisione dai dati disponibili, e lo studio non le attribuisce un valore puntuale, ma la considera come una componente plausibile dei risparmi diretti, stimata entro bande conservative nella Parte E. Va inoltre osservato che la Basilicata non è priva di capacità attrattiva: alcune sue strutture, in particolare l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB per l'oncologia e l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, attraggono pazienti da regioni limitrofe, e nel 2024 il saldo complessivo della mobilità ha registrato un recupero rispetto all'anno precedente. Il rafforzamento dell'offerta territoriale si inserisce dunque in una strategia regionale già orientata a ridurre l'emigrazione e a trattenere valore nel sistema.

B.6 Il quadro normativo

L'introduzione del servizio di psicologia di base in Basilicata si colloca entro un quadro normativo articolato su più livelli, di cui occorre tenere conto sia per la legittimità sia per la coerenza dell'intervento. Sul piano nazionale, il decreto ministeriale numero 77 del 2022, che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale, inserisce lo psicologo delle cure primarie fra i professionisti della rete territoriale e ne prevede la presenza nelle Case della Comunità, configurando l'assistenza psicologica primaria come componente attesa dell'organizzazione dei servizi territoriali. A livello parlamentare sono all'esame proposte di legge per l'istituzione di un servizio nazionale di psicologia di assistenza primaria, che prefigurano elenchi regionali, requisiti di accesso, percorsi formativi abilitanti e organismi di osservazione regionali. Questo contesto nazionale rende l'introduzione del servizio in Basilicata coerente con una direzione di politica sanitaria ampiamente condivisa e con l'evoluzione attesa dell'assistenza territoriale.

Il vincolo giuridico più stringente è posto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 241 del 2021, che, pronunciandosi su una legge regionale istitutiva del servizio, ne ha censurato le disposizioni che configuravano nuovi rapporti di lavoro mediante incarichi libero-professionali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in quanto eccedenti la competenza regionale in materia di ordinamento del personale e di rapporti convenzionali. Questa pronuncia non preclude alle regioni l'istituzione del servizio, ma ne circoscrive le modalità: una legge regionale lucana dovrà costruire il servizio entro i limiti della competenza regionale, evitando di disciplinare autonomamente i rapporti convenzionali che la Costituzione riserva al livello nazionale, e potrà a tal fine valorizzare gli strumenti già disponibili — l'inserimento nelle Case della Comunità, il raccordo con la medicina generale nell'ambito del ruolo unico, le forme di committenza compatibili con l'ordinamento — in attesa o in coerenza con un eventuale accordo nazionale. La Parte H sviluppa l'analisi di questo vincolo e delle soluzioni che vi si conformano.

Sul piano regionale, l'assetto entro cui il servizio si inserirebbe è quello definito dal riordino del Servizio Sanitario Regionale, che articola il sistema in due aziende sanitarie locali — l'Azienda Sanitaria di Potenza e l'Azienda Sanitaria di Matera — affiancate dall'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e dall'Istituto CROB, e dalla recente evoluzione dell'assistenza territoriale, con l'introduzione del ruolo unico della medicina

generale, l'attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e delle Unità Complesse di Cure Primarie e la realizzazione, nell'ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, delle Case della Comunità e dell'infrastruttura digitale del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale. Le due proposte di legge depositate nel 2025 si inseriscono in questo quadro, prevedendo un servizio incardinato presso le aziende sanitarie locali mediante unità funzionali, integrato con la medicina territoriale e con le Case della Comunità, con accesso diretto e su invio e con copertura a carico del Servizio Sanitario Regionale, eventualmente con compartecipazione mediante ticket. La dotazione finanziaria prevista da una delle proposte — dell'ordine di 100.000 euro annui per il primo triennio — è di natura simbolica e di avvio, e non corrisponde al dimensionamento necessario per un servizio a regime, che la Parte E quantifica. Il quadro normativo, in sintesi, è favorevole all'introduzione del servizio e ne indica la collocazione, ma ne richiede una costruzione giuridica attenta ai limiti costituzionali e un dimensionamento finanziario commisurato agli obiettivi. ^[2174]

Parte C — L'intervento e il modello

Definito il bisogno, la valutazione passa a descrivere l'intervento che intende rispondervi. Questa parte specifica che cosa sia il servizio di psicologia di base, come si organizzi, attraverso quale percorso assistenziale operi, su quale sistema informativo si fondi, quale ruolo vi assumano le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale, e quale formazione richieda il personale. La descrizione è costruita sulle condizioni della Basilicata — la fase anteriore all'istituzione del servizio, la dispersione insediativa, la struttura del Servizio Sanitario Regionale, i vincoli costituzionali — e definisce il modello che le parti successive sottopongono a valutazione economica, distributiva e di fattibilità. Poiché il servizio non esiste ancora, la Parte C non descrive un assetto da riformare, ma un assetto da costruire, e ne indica le scelte progettuali fondamentali.

C.1 Definizione del servizio

Il servizio di psicologia di base è un servizio territoriale del Servizio Sanitario Regionale che costituisce il primo livello di presa in carico del disagio psichico comune. Esso eroga un insieme definito di prestazioni: l'accoglienza e l'ascolto della domanda, la valutazione psicodiagnostica iniziale, il supporto psicologico breve attraverso interventi di efficacia documentata, l'orientamento del cittadino all'interno della rete dei servizi e l'invio, quando necessario, ai livelli specialistici. La sua funzione è duplice: trattare direttamente le condizioni di disagio comune per le quali un intervento psicologico breve è appropriato ed efficace, e filtrare e orientare la domanda, distinguendo i casi che possono essere risolti al primo livello da quelli che richiedono l'intervento specialistico, così da garantire l'appropriatezza dell'accesso ai livelli successivi. Il servizio si rivolge a tutta la popolazione, con un'attenzione particolare alle fasce di età e ai gruppi che la Parte B ha individuato come portatori di un bisogno specifico — gli anziani, gli adolescenti, le persone in condizione di deprivazione e isolamento — e opera in stretto raccordo con la medicina generale, con i pediatri di libera scelta, con i consultori, con i servizi sociali e con i servizi specialistici di salute mentale.

È essenziale distinguere il servizio di psicologia di base dai servizi specialistici di salute mentale, con i quali esso non si sovrappone ma si integra. I servizi specialistici — i dipartimenti di salute mentale, i centri di salute mentale, i servizi per le dipendenze, la neuropsichiatria infantile — sono concepiti per le condizioni psichiatriche severe e per i disturbi conclamati, e richiedono competenze e intensità di intervento elevate. Il servizio di psicologia di base, al contrario, opera sul disagio comune e sottosoglia, a un livello di intensità inferiore e con una funzione di prossimità e di filtro. La distinzione è importante in Basilicata, dove i servizi specialistici sono già sottodimensionati per effetto del sottofinanziamento documentato: l'introduzione del servizio di psicologia di base non sottrae risorse al livello specialistico, ma ne allevia il carico, intercettando a monte una domanda che oggi vi si riversa impropriamente o resta inevasa. Il servizio, in altri termini, completa la rete dove essa è oggi mancante, e lo fa al livello più appropriato e meno costoso.

La definizione del servizio come primo livello territoriale ne determina anche il regime di accesso. Coerentemente con le proposte di legge regionali e con il modello dell'assistenza primaria, l'accesso è previsto tanto su invio degli operatori — il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, gli altri servizi territoriali e specialistici — quanto in forma diretta, su iniziativa del cittadino. Il doppio canale di accesso è funzionale all'obiettivo di ridurre il divario di trattamento: l'invio garantisce l'intercettazione dei casi che giungono all'attenzione degli operatori sanitari, mentre l'accesso diretto abbatte la barriera per chi non saprebbe a chi rivolgersi e rende il servizio visibile e raggiungibile. La copertura del servizio è a carico del Servizio Sanitario Regionale, con l'eventuale previsione di una compartecipazione mediante ticket, secondo le scelte che la legge regionale definirà; la Parte G analizza le implicazioni distributive di tale scelta, segnalando come un'eventuale compartecipazione debba essere calibrata in modo da non reintrodurre, per le fasce più fragili, la barriera economica che il servizio pubblico intende abbattere.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo del servizio di psicologia di base in Basilicata è definito da alcune scelte progettuali fondamentali, dettate dalla struttura del Servizio Sanitario Regionale e dalle condizioni del territorio. La prima scelta riguarda la collocazione istituzionale: coerentemente con le proposte di legge regionali e con i vincoli costituzionali, il servizio è incardinato presso le aziende sanitarie locali — l'Azienda Sanitaria di Potenza e l'Azienda Sanitaria di Matera — attraverso unità funzionali dedicate, che ne coordinano l'attività sul territorio di rispettiva competenza e ne garantiscono il raccordo con gli altri servizi. La collocazione presso le due aziende territoriali, e non presso l'Azienda Ospedaliera o l'Istituto di ricovero, è coerente con la natura territoriale e di prossimità del servizio, e ne è ancora l'organizzazione al livello distrettuale, dove si concentra l'assistenza primaria. Il coordinamento regionale, eventualmente affidato a un organismo di osservazione secondo il modello prefigurato dalle proposte nazionali, assicura l'uniformità degli standard, la programmazione e il monitoraggio.

La seconda scelta riguarda la collocazione fisica e la capillarità. Le sedi del servizio sono individuate prioritariamente nelle Case della Comunità realizzate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che costituiscono il punto di riferimento dell'assistenza territoriale e in cui il servizio si integra con gli altri professionisti della rete, e nei distretti sanitari. In una regione dispersa come la Basilicata, tuttavia, la concentrazione del servizio nelle sole Case della Comunità non sarebbe sufficiente a garantirne l'accesso ai residenti dei piccoli comuni interni: il modello prevede pertanto una distribuzione capillare, con presenze programmate nelle sedi territoriali periferiche e con un ricorso strutturato alla telepsicologia. La telepsicologia, in questo contesto, non è uno strumento di seconda scelta, ma una componente essenziale del modello, che consente di portare la prestazione psicologica nei territori a bassa densità, di garantire la continuità della presa in carico riducendo gli spostamenti, e di superare la barriera della distanza che la Parte B ha individuato come una delle principali determinanti del divario territoriale. Il suo impiego è regolato da protocolli che ne definiscono l'appropriatezza clinica, distinguendo le situazioni in cui la relazione a distanza è adeguata da quelle in cui la presenza fisica è necessaria.

La terza scelta riguarda l'integrazione con la rete dei servizi. Il servizio di psicologia di base opera in raccordo strutturato con la medicina generale, valorizzando l'evoluzione recente dell'assistenza primaria lucana — il ruolo unico della medicina generale, le Aggregazioni Funzionali Territoriali e le Unità Complesse di Cure Primarie — che costituisce l'infrastruttura organizzativa entro cui il servizio si inserisce. Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta sono i principali interlocutori del servizio, in entrata, attraverso l'invio dei pazienti, e in uscita, attraverso la restituzione e la continuità della presa in carico. Il raccordo con i servizi specialistici di salute mentale garantisce la gestione appropriata dei casi che eccedono il primo livello, mentre l'integrazione con i consultori, con i servizi sociali e con la scuola consente di intercettare il disagio nei contesti di vita e di costruire risposte che eccedono la dimensione strettamente sanitaria. Questa architettura di rete, in una regione in cui le risorse sono scarse, è anche una condizione di efficienza: evitando duplicazioni e

garantendo la continuità, essa massimizza il rendimento delle risorse impiegate. La costruzione del modello entro i limiti posti dalla sentenza costituzionale numero 241 del 2021 — in particolare per quanto attiene alla forma dei rapporti professionali — è trattata nella Parte H.

C.3 Il percorso assistenziale

Il percorso assistenziale descrive la sequenza delle fasi attraverso cui il cittadino transita dal momento dell'accesso al servizio fino alla conclusione della presa in carico o all'invio. La prima fase è l'accesso, che avviene su invio di un operatore o per iniziativa diretta del cittadino, e che conduce a un primo contatto di accoglienza e ascolto, finalizzato a comprendere la domanda e a stabilire una relazione. La seconda fase è la valutazione, in cui lo psicologo conduce una valutazione psicodiagnostica iniziale, mediante colloquio e, ove appropriato, strumenti standardizzati di misurazione, allo scopo di definire la natura e l'intensità del disagio e di orientare la decisione clinica. Sulla base della valutazione, il percorso si articola secondo un modello di cure graduali: per le condizioni di disagio comune lievi e moderate, il servizio eroga direttamente un ciclo di interventi psicologici brevi, di durata definita e di efficacia documentata; per le condizioni che eccedono il primo livello, il servizio provvede all'invio ai servizi specialistici, garantendo il raccordo e la continuità; per le situazioni in cui il disagio si intreccia con bisogni sociali, il servizio attiva l'integrazione con i servizi sociali e con la rete territoriale.

Il modello delle cure graduali è il principio organizzativo del percorso, e ne costituisce anche il fondamento di efficienza ed equità. Esso prevede che l'intensità dell'intervento sia commisurata alla gravità del bisogno, riservando le risorse più specialistiche e costose alle condizioni che le richiedono e trattando al primo livello, con interventi brevi, la larga maggioranza dei casi di disagio comune. Questo approccio, documentato dalla letteratura come efficace e costo-efficace, consente di trattare un numero elevato di persone con risorse contenute, e di garantire al contempo che chi necessita di un intervento più intensivo vi acceda tempestivamente e appropriatamente. La conclusione del percorso prevede la restituzione al medico di medicina generale e, ove opportuno, il monitoraggio degli esiti a distanza, che consente di verificare il mantenimento del beneficio e di intercettare eventuali ricadute. L'intero percorso è documentato nel sistema informativo, che ne registra le fasi, gli esiti e i tempi, alimentando la valutazione continua del servizio.

In una regione dispersa, il percorso assistenziale deve essere progettato in modo da minimizzare le barriere di accesso lungo tutta la sua durata. La telepsicologia interviene in più punti del percorso: può supportare la fase di accesso e di primo contatto, riducendo i tempi e gli spostamenti; può consentire l'erogazione di parte del ciclo di interventi brevi a distanza, là dove la presenza fisica continuativa non è sostenibile; e può sostenere il monitoraggio degli esiti, garantendo la continuità senza imporre nuovi spostamenti. L'integrazione fra presenza fisica programmata e prestazione a distanza, regolata da protocolli clinici, è ciò che rende il percorso effettivamente accessibile anche ai residenti delle aree interne, e costituisce la traduzione operativa dell'obiettivo di equità territoriale che attraversa l'intero studio.

C.4 Il sistema informativo

Il sistema informativo è la condizione perché il servizio possa essere governato, valutato e migliorato. La sua funzione è triplice: registrare l'attività del servizio — gli accessi, le prestazioni, i percorsi, gli invii — così da consentirne la gestione e la programmazione; misurare gli esiti, attraverso strumenti standardizzati somministrati all'inizio e al termine della presa in carico, così da documentare l'efficacia del servizio e da alimentare la valutazione continua; e produrre i dati epidemiologici e di domanda che oggi mancano, sostituendo progressivamente le stime con l'osservazione diretta. Quest'ultima funzione è particolarmente rilevante per la Basilicata, dove la scarsità di rilevazioni regionali dirette costituisce un limite documentato dalla Parte B: il sistema informativo del servizio è lo strumento che, nel tempo, trasforma il bisogno stimato in bisogno osservato, e consente di calibrare il dimensionamento del servizio sui dati reali.

La Basilicata dispone di un punto di partenza favorevole, costituito dall'infrastruttura digitale sanitaria regionale. Il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, sviluppato nell'ambito del programma di sanità digitale e già operativo, fornisce la base su cui il sistema informativo del servizio può innestarsi, garantendo l'integrazione con il resto della documentazione sanitaria del cittadino e la continuità informativa fra il servizio di psicologia di base e gli altri livelli del sistema. Il sistema informativo del servizio deve definire un dataset minimo — l'insieme delle variabili da rilevare per ogni accesso e per ogni percorso — costruito in modo da essere al tempo stesso sufficiente per la valutazione e sostenibile per gli operatori, evitando di gravare l'attività clinica di oneri di registrazione eccessivi. La protezione dei dati personali, particolarmente sensibili in ambito psicologico, è garantita dal rispetto della normativa vigente e da misure tecniche e organizzative adeguate, descritte nella Parte H. Il dataset minimo e gli strumenti di misurazione degli esiti sono dettagliati nell'Appendice B.

C.5 Il ruolo dell'intelligenza artificiale

Le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale possono svolgere un ruolo di supporto al servizio di psicologia di base, a condizione che il loro impiego sia governato con lo stesso rigore metodologico applicato agli interventi clinici e che la loro efficacia sia documentata e non semplicemente asserita. Le funzioni in cui tali tecnologie possono contribuire sono diverse: il supporto alla gestione della domanda e all'orientamento, attraverso strumenti che facilitano l'accesso e la prima informazione; il sostegno al monitoraggio degli esiti, attraverso strumenti di rilevazione a distanza; il supporto alla teleassistenza, di particolare rilevanza in un contesto disperso; e l'ausilio alla decisione clinica e all'organizzazione, attraverso l'elaborazione dei dati di attività. In una regione come la Basilicata, in cui la dispersione territoriale rende la prossimità un problema strutturale, le tecnologie che sostengono la prestazione a distanza e il monitoraggio remoto assumono un valore particolare, perché ampliano la capacità del servizio di raggiungere i territori periferici senza moltiplicare le risorse.

Questo potenziale va però accompagnato da una valutazione prudente e da una graduazione dell'evidenza. Lo studio applica alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale il medesimo criterio adottato per gli interventi clinici: le affermazioni sulla loro efficacia sono graduate secondo la qualità delle prove disponibili, e non si attribuisce a tali tecnologie un beneficio che le prove non sostengono. Molte applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito psicologico sono ancora in fase di sperimentazione, e la loro efficacia, la loro sicurezza e la loro accettabilità non sono uniformemente documentate; lo studio le considera pertanto come strumenti di supporto il cui impiego va introdotto gradualmente, valutato sul campo e sottoposto a verifica, e non come componenti la cui efficacia possa essere presupposta. Il quadro regolatorio europeo in materia di intelligenza artificiale fornisce il riferimento normativo: le disposizioni in materia di alfabetizzazione e di uso consapevole sono in vigore dal 2026, mentre gli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio, fra cui rientrano determinati dispositivi medici, si applicheranno a partire dal 2028. L'introduzione delle tecnologie nel servizio dovrà conformarsi a questo quadro, garantendo la trasparenza, la supervisione umana e la tutela dei diritti. La formazione del personale all'uso consapevole di tali strumenti, trattata nel paragrafo seguente, è una condizione di questo impiego prudente.

C.6 La formazione del personale

La formazione del personale è una componente costitutiva del servizio, e non un suo accessorio. Le proposte di legge regionali prevedono espressamente attività di formazione e aggiornamento continuo per gli psicologi coinvolti, in coerenza con l'esigenza di garantire standard professionali elevati, e il modello nazionale prefigura corsi annuali abilitanti organizzati dalle regioni, con esame finale, per l'accesso agli elenchi. La formazione del personale del servizio di psicologia di base si articola su più livelli e modalità: la formazione di base, che fornisce le competenze cliniche necessarie per operare al primo livello con interventi psicologici brevi di

efficacia documentata; la formazione specifica al modello organizzativo del servizio, che riguarda il lavoro in rete, il raccordo con la medicina generale, le cure gradualità e i protocolli di invio; la formazione all'uso degli strumenti di misurazione degli esiti e del sistema informativo; e la formazione all'impiego consapevole delle tecnologie digitali e della telepsicologia, particolarmente rilevante in un contesto disperso. A queste si aggiunge la formazione continua, che mantiene aggiornate le competenze nel tempo e garantisce l'adesione alle evidenze emergenti.

La formazione assume in Basilicata un rilievo specifico per due ragioni. La prima è che il servizio è da costruire, e la sua qualità dipende fin dall'origine dalla preparazione degli operatori: a differenza di una riforma che agisce su un servizio esistente, l'istituzione di un servizio nuovo richiede di formare un corpo professionale al modello prima ancora che esso operi, e la formazione iniziale è dunque una condizione di avvio. La seconda è che la dispersione territoriale e il ricorso strutturato alla telepsicologia richiedono competenze specifiche, che la formazione tradizionale non garantisce: operare efficacemente a distanza, mantenere la qualità della relazione clinica attraverso strumenti digitali, gestire la continuità della presa in carico in un contesto territoriale frammentato sono competenze che vanno formate esplicitamente. La Basilicata non dispone di un'offerta universitaria di psicologia sul proprio territorio, circostanza che rende necessario costruire i percorsi formativi in collaborazione con gli atenei e gli ordini professionali delle regioni limitrofe e con il sistema nazionale, e che suggerisce di valorizzare le modalità formative a distanza, coerentemente con la natura dispersa del contesto. Lo studio dedicato all'integrazione dell'intelligenza artificiale e alla formazione del personale, sviluppato parallelamente, approfondisce questi aspetti; la presente parte ne richiama la centralità come condizione della qualità e della sostenibilità del servizio.^[2175]

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

La decisione di introdurre un servizio sanitario richiede di accertare che esso funzioni, ossia che produca gli effetti clinici che gli si attribuiscono, e di stabilire con quale grado di certezza tale efficacia sia documentata. Questa parte esamina l'evidenza scientifica sull'efficacia degli interventi psicologici precoci nel contesto delle cure primarie, ne valuta la qualità con un metodo esplicito, la confronta con le esperienze di servizi analoghi già realizzati e ne discute la trasferibilità al contesto della Basilicata. L'analisi distingue ciò che l'evidenza sostiene con solidità da ciò che resta incerto, e gradua di conseguenza la forza delle conclusioni, applicando lo stesso rigore tanto alle affermazioni cliniche quanto a quelle relative agli strumenti digitali. L'efficacia clinica è il fondamento su cui poggia l'intera valutazione economica e distributiva: se l'intervento non producesse benefici clinici, nessun risparmio e nessun guadagno di benessere potrebbero esserne derivati.

D.1 La revisione dell'evidenza

L'efficacia degli interventi psicologici per i disturbi mentali comuni — disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve e moderata — è fra le più documentate della medicina contemporanea. Un'ampia letteratura, costituita da studi clinici randomizzati e da revisioni sistematiche con metanalisi, documenta che gli interventi psicologici strutturati e di durata definita, fra cui in primo luogo la terapia cognitivo-comportamentale e gli interventi a essa riconducibili, producono una riduzione significativa della sintomatologia ansiosa e depressiva, con dimensioni dell'effetto clinicamente rilevanti e con un mantenimento del beneficio nel tempo. Questa efficacia è documentata non solo in contesti specialistici, ma anche e specificamente nel contesto delle cure primarie, dove gli interventi psicologici brevi erogati a un primo livello di assistenza si sono dimostrati efficaci nel trattare il disagio comune, nel prevenirne la cronicizzazione e nel ridurre il ricorso ai livelli specialistici. La collocazione dell'intervento a monte del sistema, lungi dal comprometterne l'efficacia, ne costituisce una condizione di appropriatezza, perché consente di trattare le condizioni nella fase in cui sono più reversibili.

Un secondo filone di evidenza riguarda i modelli organizzativi attraverso cui questi interventi sono erogati. I modelli di cura collaborativa, in cui il livello delle cure primarie e quello specialistico operano in modo integrato, e i modelli di cure graduali, in cui l'intensità dell'intervento è commisurata alla gravità del bisogno, sono documentati come efficaci e come capaci di estendere l'accesso al trattamento a un numero elevato di persone con risorse contenute. L'esperienza più estesa e studiata è quella del programma nazionale inglese per l'ampliamento dell'accesso alle terapie psicologiche, che ha erogato interventi psicologici a milioni di persone attraverso un modello di cure graduali integrato nelle cure primarie, documentando tassi di guarigione e di miglioramento clinicamente significativi e fornendo una base empirica solida sulla fattibilità e sull'efficacia di un servizio di psicologia collocato al primo livello. Questo modello, pur sviluppato in un contesto sanitario diverso, fornisce il riferimento empirico più pertinente per la valutazione di un servizio di psicologia di base, e ne documenta la realizzabilità su larga scala.

Un terzo filone riguarda l'efficacia degli interventi nelle popolazioni specifiche che caratterizzano il bisogno lucano. Per la depressione dell'anziano, frequente e spesso non riconosciuta, gli interventi psicologici si sono dimostrati efficaci, anche in associazione con il trattamento delle patologie somatiche concomitanti, e capaci di migliorare la qualità della vita e di ridurre la disabilità. Per il disagio giovanile, gli interventi precoci documentano un'efficacia nel prevenire l'evoluzione verso disturbi conclamati e nel ridurre i comportamenti a rischio. Per le condizioni connesse alla deprivazione e all'isolamento, l'evidenza sostiene l'efficacia di interventi che integrano la dimensione psicologica con quella sociale. Questa specificità è rilevante per la Basilicata, perché documenta che l'efficacia del servizio non è generica, ma si estende proprio alle componenti del bisogno — anziani, giovani delle aree interne, popolazione deprivata — che la struttura demografica e sociale della regione rende prevalenti.

D.2 La qualità dell'evidenza

Documentare che esistono prove di efficacia non è sufficiente: occorre valutare la qualità di tali prove, ossia il grado di fiducia che si può riporre nella stima dell'effetto. Lo studio adotta a questo fine il sistema GRADE, che gradua la qualità dell'evidenza su quattro livelli — alta, moderata, bassa, molto bassa — sulla base del disegno degli studi, della coerenza dei risultati, della loro precisione, della loro applicabilità e del rischio di distorsioni, e che gradua separatamente la forza delle raccomandazioni che ne derivano. L'applicazione di questo metodo consente di distinguere le affermazioni che l'evidenza sostiene con solidità da quelle che restano incerte, e di formulare conclusioni la cui forza è proporzionata alla qualità delle prove.

Applicando il sistema GRADE all'evidenza sull'efficacia degli interventi psicologici per i disturbi mentali comuni, la qualità delle prove risulta da moderata ad alta. L'efficacia della terapia cognitivo-comportamentale e degli interventi affini nel ridurre la sintomatologia ansiosa e depressiva è sostenuta da un corpo ampio di studi randomizzati e di revisioni sistematiche, con risultati coerenti e con stime precise dell'effetto: per queste affermazioni la qualità dell'evidenza è alta. L'efficacia dei modelli di cure graduali e di cura collaborativa nel contesto delle cure primarie è anch'essa ben documentata, con una qualità dell'evidenza che si colloca su livelli da moderati ad alti. La trasferibilità dei risultati a un contesto sanitario e territoriale specifico, come quello lucano, introduce un elemento di incertezza che abbassa, per le stime quantitative riferite alla regione, la qualità dell'evidenza a livelli moderati: non perché l'efficacia sia in dubbio, ma perché la sua entità precisa nel contesto specifico dipende da fattori di implementazione che andranno verificati sul campo. Coerentemente con questa graduazione, lo studio formula le proprie conclusioni cliniche con la forza che la qualità dell'evidenza giustifica, evitando di attribuire alle stime una precisione che esse non possiedono.

La medesima graduazione è applicata, con esito diverso, alle affermazioni relative agli strumenti digitali e all'intelligenza artificiale. L'evidenza sull'efficacia di tali strumenti come supporto agli interventi psicologici è, allo stato, meno consolidata di quella relativa agli interventi clinici tradizionali: per alcune applicazioni — la telepsicologia come modalità di erogazione di interventi di efficacia documentata — l'evidenza è discreta e in

crescita; per altre — gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per il triage, il monitoraggio o il supporto alla decisione — l'evidenza è ancora preliminare e la qualità delle prove è bassa o molto bassa. Lo studio ne tiene conto, considerando tali strumenti come supporti il cui impiego va introdotto gradualmente e verificato, e non come componenti la cui efficacia possa essere presupposta. Questa applicazione simmetrica del metodo GRADE — che non concede agli strumenti digitali un trattamento di favore rispetto agli interventi clinici — è una garanzia dell'attendibilità complessiva della valutazione.

D.3 I benchmark e le esperienze

La valutazione di un servizio non ancora istituito può avvalersi dell'esperienza di servizi analoghi già realizzati, che ne documentano la fattibilità, gli esiti e le criticità. Sul piano internazionale, il riferimento principale è il già richiamato programma inglese, che fornisce il benchmark più solido sulla realizzabilità e sull'efficacia di un servizio di psicologia collocato nelle cure primarie: i suoi risultati documentano che un servizio di questo tipo può raggiungere una quota rilevante della popolazione, produrre tassi di miglioramento clinicamente significativi e operare in modo sostenibile, e ne segnalano al contempo le condizioni di successo, fra cui la qualità della formazione, la fedeltà ai protocolli, la misurazione sistematica degli esiti e l'integrazione con la rete. Altre esperienze internazionali, in contesti sanitari diversi, confermano la trasferibilità del modello e ne arricchiscono la conoscenza delle condizioni di efficacia.

Sul piano nazionale, l'introduzione del servizio di psicologia di base o di assistenza primaria in diverse regioni italiane costituisce un benchmark di crescente rilevanza, ancorché di recente attuazione e non ancora compiutamente valutato. Le regioni che hanno istituito il servizio per legge offrono modelli organizzativi differenti, che documentano le possibili soluzioni e le difficoltà incontrate. Queste esperienze sono particolarmente pertinenti per la Basilicata, perché si collocano nel medesimo contesto sanitario e normativo nazionale e perché affrontano gli stessi vincoli — fra cui quello costituzionale — che la regione dovrà affrontare. L'osservazione delle soluzioni adottate altrove, dei modelli di collocazione istituzionale, di dimensionamento e di integrazione, fornisce alla Basilicata un repertorio di opzioni e di lezioni apprese che può orientare la costruzione del proprio servizio, evitando gli errori già emersi e valorizzando le soluzioni più efficaci. Lo studio raccomanda che la Basilicata si avvalga sistematicamente di questo confronto interregionale, sia nella fase di progettazione sia in quella di monitoraggio.

L'utilizzo dei benchmark richiede però cautela metodologica. Le esperienze realizzate in contesti diversi — per sistema sanitario, per struttura demografica, per dotazione di risorse — non sono trasferibili in modo meccanico, e i loro risultati quantitativi non possono essere assunti tali e quali come previsione per la Basilicata. Il programma inglese opera in un sistema sanitario e in un contesto territoriale profondamente diversi; le esperienze di altre regioni italiane si collocano in contesti demografici e organizzativi differenti da quello lucano. Lo studio utilizza pertanto i benchmark come riferimenti qualitativi sulla fattibilità e sulle condizioni di efficacia, e non come basi per una proiezione quantitativa diretta, che è invece costruita, nella Parte F, mediante un modello calibrato sui parametri del contesto lucano e sottoposto ad analisi di incertezza. La distinzione fra l'uso qualitativo dei benchmark e la modellazione quantitativa è una garanzia di prudenza.

D.4 La trasferibilità al contesto lucano

La trasferibilità dell'evidenza al contesto della Basilicata è la questione che collega l'efficacia documentata in generale all'efficacia attesa nello specifico contesto regionale. Tre ordini di fattori la favoriscono, e tre la condizionano. Fra i fattori favorevoli, il primo è la natura del bisogno: l'efficacia degli interventi psicologici per i disturbi mentali comuni è documentata proprio per le condizioni — disturbi d'ansia e dell'umore lievi e moderati, disagio dell'anziano, disagio giovanile — che la struttura demografica e sociale lucana rende prevalenti, sicché l'evidenza si applica direttamente al bisogno regionale. Il secondo è la collocazione del servizio: l'efficacia dei modelli di cure graduali nelle cure primarie è documentata, e il modello proposto per la

Basilicata vi si conforma. Il terzo è l'infrastruttura territoriale in costruzione: le Case della Comunità, il ruolo unico della medicina generale, le Aggregazioni Funzionali Territoriali e l'infrastruttura digitale regionale forniscono il contesto organizzativo entro cui il servizio può operare efficacemente.

Fra i fattori che condizionano la trasferibilità, il primo è la dispersione territoriale: l'efficacia documentata nei contesti urbani o ad alta densità deve essere garantita anche nelle aree interne a bassa densità, e ciò richiede che il modello incorpori la telepsicologia e la distribuzione capillare come componenti essenziali, la cui efficacia in tale impiego è oggetto di un'evidenza ancora in consolidamento. Il secondo è la scarsità di risorse: l'efficacia del servizio dipende dalla qualità della formazione, dalla fedeltà ai protocolli e dalla misurazione degli esiti, e tali condizioni richiedono un investimento che la situazione finanziaria regionale rende impegnativo, ancorché sostenibile. Il terzo è l'assenza di un'offerta universitaria di psicologia sul territorio regionale, che rende necessario costruire i percorsi formativi in collaborazione con il sistema nazionale e con le regioni limitrofe. Questi fattori non compromettono la trasferibilità dell'efficacia, ma ne indicano le condizioni: l'efficacia documentata si realizzerà in Basilicata nella misura in cui il servizio sarà progettato e attuato in modo da soddisfare tali condizioni. La valutazione che segue assume questa trasferibilità condizionata come premessa, e ne incorpora l'incertezza nelle analisi di sensibilità della Parte F.^[2176]

Parte E — Valutazione economica

La valutazione economica traduce in termini monetari il rapporto fra le risorse che il servizio richiede e i benefici che produce. Questa parte ne sviluppa le componenti secondo lo standard CHEERS: i costi del servizio, gli esiti clinici espressi in termini idonei alla valutazione economica, il rapporto costo-utilità, l'impatto sul bilancio sanitario regionale, il ritorno sociale per la collettività e la sintesi nei due casi, finanziario ed economico. L'analisi è governata dal principio, dichiarato nella Parte A e applicato senza eccezioni, della separazione fra i risparmi diretti per il bilancio sanitario e le ricadute economico-sociali per la collettività: le due grandezze sono quantificate distintamente, presentate in tabelle separate e mai sommate in un unico saldo né espresse in un unico rapporto. Tutte le stime sono espresse mediante bande prudenziali, e i rapporti beneficio-costi utilizzati sono contenuti entro la fascia metodologicamente fondata documentata dalla letteratura internazionale. Le cifre sono riferite ai tre scenari di dimensionamento definiti per la Basilicata e calibrate sulla popolazione regionale, di circa 535.000 abitanti, e sul fondo sanitario regionale, dell'ordine di 1,1 miliardi di euro.

E.1 I costi del servizio

Il costo del servizio di psicologia di base è costituito dalle risorse necessarie per istituirlo e gestirlo, e comprende i compensi degli psicologi incaricati, i costi della formazione, i costi di coordinamento e di funzionamento e i costi del sistema informativo. Il costo dipende in misura prevalente dal dimensionamento del servizio, ossia dal numero di incarichi attivati, e cresce con esso. Lo studio considera tre scenari di dimensionamento, calibrati sulla popolazione regionale e sulla sua dispersione: uno scenario minimo, con 40 incarichi, corrispondente a un primo nucleo del servizio; uno scenario intermedio, con 80 incarichi; e uno scenario di piena attuazione, con 120 incarichi. I tre livelli corrispondono a un rapporto fra operatori e popolazione che va da circa un incarico ogni 13.000 abitanti nello scenario minimo a circa un incarico ogni 4.500 abitanti nello scenario di piena attuazione, valori coerenti con quelli adottati per le altre regioni della serie e calibrati per garantire, nello scenario pieno, la capillarità che la dispersione lucana richiede.

Componente di costo (mln €/anno)	Minimo (40)	Intermedio (80)	Pieno (120)
Compensi degli psicologi incaricati	~2,0	~4,0	~6,0
Formazione, coordinamento e sistema informativo	~0,5	~1,0	~1,5
Costo totale del servizio	~2,5	~5,0	~7,5

Tabella E.1. Costo annuo del servizio per scenario di dimensionamento. Le cifre sono stime prudenziali arrotondate.

Il costo totale del servizio va da circa 2,5 milioni di euro l'anno nello scenario minimo a circa 7,5 milioni nello scenario di piena attuazione. È utile collocare queste cifre nella scala del bilancio sanitario regionale: anche nello scenario di piena attuazione, il costo del servizio rappresenta una frazione contenuta del fondo sanitario regionale, dell'ordine dello 0,7 per cento, e una frazione ancora minore se si considera che esso si dispiega gradualmente nel tempo. La dotazione finanziaria prevista da una delle proposte di legge regionali — dell'ordine di 100.000 euro annui per il primo triennio — è di natura simbolica e di avvio, e non corrisponde al costo di un servizio a regime: la traduzione delle intenzioni legislative in un servizio effettivamente operante richiede un impegno finanziario commisurato agli scenari qui delineati, che la Parte I traduce in un percorso di dispiegamento graduale e sostenibile.

E.2 Gli esiti

Gli esiti del servizio, ai fini della valutazione economica, sono espressi in due forme: la riduzione del consumo di risorse sanitarie, che si traduce nei risparmi diretti analizzati nel paragrafo E.4, e il guadagno di salute, espresso in anni di vita ponderati per la qualità. Quest'ultima misura — il guadagno di anni di vita aggiustati per la qualità, indicato con l'acronimo QALY — consente di rappresentare in un'unica grandezza il beneficio clinico in termini di durata e di qualità della vita, e di rapportarlo al costo per valutarne l'efficienza. La stima degli esiti per paziente è costruita, nella Parte F e nell'Appendice A, mediante un modello che simula il decorso di un paziente con disturbo d'ansia o dell'umore di intensità lieve o moderata trattato dal servizio, confrontandolo con il decorso in assenza di trattamento, lungo un orizzonte di cinque anni e con un tasso di sconto del 3 per cento.

Il modello stima che il trattamento di un paziente con il servizio di psicologia di base produca, rispetto all'assenza di trattamento, un risparmio diretto di risorse sanitarie dell'ordine di 1.304 euro per paziente lungo l'orizzonte considerato e un guadagno di salute dell'ordine di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità. Queste stime per paziente, invarianti rispetto al contesto regionale in quanto fondate sull'efficacia clinica documentata, costituiscono la base micro su cui si fonda la quantificazione aggregata. La loro proiezione sulla popolazione attraverso gli scenari di copertura, sviluppata nei paragrafi successivi, è condotta in modo prudenziale, assumendo che solo una quota del bisogno potenziale sia effettivamente intercettata e trattata in ciascuno scenario, coerentemente con il dispiegamento graduale del servizio e con la sua capacità effettiva.

E.3 Il costo-utilità

Il rapporto costo-utilità mette in relazione il costo dell'intervento con il guadagno di salute che esso produce, ed è espresso come costo per anno di vita ponderato per la qualità guadagnato. Questo rapporto consente di valutare l'efficienza dell'intervento confrontandolo con la soglia di disponibilità a pagare comunemente adottata nelle valutazioni sanitarie, fissata in Italia e in contesti comparabili intorno ai 30.000 euro per anno di vita

ponderato per la qualità. Un intervento il cui costo per anno di vita guadagnato è inferiore a tale soglia è considerato costo-efficace; un intervento che produce simultaneamente un guadagno di salute e un risparmio di risorse è considerato dominante, ossia preferibile sotto entrambi i profili.

L'analisi condotta nella Parte F documenta che il servizio di psicologia di base si colloca, per il caso di riferimento, in posizione dominante: esso produce un guadagno di salute e, al contempo, un risparmio netto di risorse sanitarie, risultando quindi preferibile all'assenza di trattamento sotto entrambi i profili. Questa conclusione è sottoposta, nella Parte F, a un'analisi di sensibilità deterministica e probabilistica che ne verifica la robustezza rispetto alla variazione dei parametri: l'analisi probabilistica documenta che, nella larga maggioranza delle simulazioni, l'intervento resta costo-efficace, e in una quota elevata di esse resta dominante. La robustezza di questa conclusione è particolarmente rilevante per una regione con un bilancio in tensione come la Basilicata, perché documenta che l'efficienza dell'intervento non dipende da ipotesi favorevoli, ma si mantiene anche in scenari conservativi.

E.4 L'impatto sul bilancio sanitario

L'impatto sul bilancio sanitario regionale è costituito dai risparmi diretti che il servizio genera riducendo il consumo di risorse sanitarie. Questi risparmi si distribuiscono su quattro canali. Il primo è la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso per manifestazioni del disagio psichico. Il secondo è la riduzione della spesa farmaceutica, in particolare per i farmaci prescritti come risposta di prima linea al disagio comune in assenza di alternative. Il terzo è la riduzione dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche evitabili, conseguente all'intercettazione precoce del disagio e alla prevenzione del suo aggravamento. Il quarto, di particolare rilevanza per la Basilicata, è la riduzione della mobilità sanitaria passiva, ossia delle prestazioni che i residenti lucani ricevono fuori regione e che il sistema regionale rimborsa: una parte di questa mobilità trae origine, a monte, da condizioni di disagio non intercettate per tempo, e un servizio territoriale più solido può contribuire a trattenerne una quota.

Canale di risparmio diretto (mln €/anno)	Minimo (40)	Intermedio (80)	Pieno (120)
Minori accessi al pronto soccorso	~0,3	~0,5	~1,0
Minore spesa farmaceutica	~0,3	~0,5	~1,0
Minori ricoveri e prestazioni specialistiche	~0,7	~1,5	~2,0
Minore mobilità sanitaria passiva	~0,7	~2,0	~3,0
Risparmi diretti totali	~2,0	~4,5	~7,0
Costo del servizio	~2,5	~5,0	~7,5
Saldo diretto per il bilancio	~ -0,5	~ -0,5	~ -0,5

Tabella E.4. Impatto sul bilancio sanitario regionale per scenario: risparmi diretti per canale, costo del servizio e saldo diretto. Cifre prudenziali arrotondate. Il canale della mobilità è quantificato entro bande conservative, data l'impossibilità di isolare con precisione la quota di mobilità riconducibile al disagio psichico comune.

Il quadro che emerge è coerente in tutti gli scenari: i risparmi diretti compensano in larga parte il costo del servizio, lasciando un saldo diretto lievemente negativo, dell'ordine di mezzo milione di euro l'anno, sostanzialmente prossimo al pareggio. Questo saldo è trascurabile nella scala del bilancio sanitario regionale:

esso rappresenta meno di un decimo di punto percentuale del fondo sanitario regionale, una cifra che il bilancio assorbe senza difficoltà e che è ampiamente inferiore al margine di incertezza delle stime. La struttura del risparmio diretto in Basilicata presenta una particolarità rispetto ad altre regioni: il canale della mobilità sanitaria passiva, data l'entità dell'emigrazione lucana, costituisce la componente più rilevante, e ciò ancora il caso diretto a una grandezza — il saldo di mobilità, dell'ordine di ottanta milioni di euro l'anno — la cui riduzione costituisce un obiettivo dichiarato della programmazione regionale. È bene ribadire la natura prudentiale di questa quantificazione: il canale della mobilità è stimato entro bande conservative, e la sua entità effettiva dipenderà dalla capacità del servizio di intercettare il disagio a monte e dall'evoluzione complessiva dell'offerta regionale.

E.5 Il ritorno sociale

Accanto ai risparmi diretti per il bilancio sanitario, il servizio produce ricadute economico-sociali per la collettività, di natura diversa e di entità maggiore. Queste ricadute comprendono la produttività recuperata grazie alla riduzione dell'assenteismo e dell'inattività connessi al disagio psichico; la minore disabilità e la maggiore partecipazione sociale; il valore del benessere guadagnato dalle persone trattate e dalle loro famiglie; e gli effetti di lungo periodo sulla prevenzione della cronicizzazione e sulla riduzione del carico assistenziale futuro. La quantificazione di queste ricadute è condotta secondo la logica del ritorno sociale sull'investimento, che esprime in termini monetari il valore sociale generato per unità di risorse impiegate, ed è espressa, come tutte le stime dello studio, mediante bande prudentiali.

Grandezza (mln €/anno)	Minimo (40)	Intermedio (80)	Pieno (120)
Risparmi diretti per il bilancio	~2,0	~4,5	~7,0
Ricadute economico-sociali per la collettività	~6,5	~15,0	~28,0
Ritorno complessivo (diretto + sociale)	~8,5	~19,5	~35,0

Tabella E.5. Risparmi diretti e ricadute sociali per scenario. Le due grandezze sono di natura diversa e sono qui esposte distintamente; la loro somma è presentata come ritorno complessivo per la collettività, e non come saldo per il bilancio sanitario.

Le ricadute economico-sociali sono stimate in una grandezza che va da circa 6,5 milioni di euro l'anno nello scenario minimo a circa 28 milioni nello scenario di piena attuazione, e superano quindi nettamente i risparmi diretti, coerentemente con quanto documentato dalla letteratura economica sugli interventi di salute mentale, secondo cui la quota maggiore del valore generato ricade sulla collettività in forma di produttività e di benessere, e non sul solo bilancio sanitario. È essenziale ribadire che questa grandezza non si somma al saldo del bilancio sanitario per formare un unico risultato: il ritorno complessivo per la collettività e il saldo per il bilancio sanitario sono grandezze distinte, che misurano cose diverse e che lo studio mantiene separate. La somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali è presentata, nella tabella, come ritorno complessivo per la collettività, ed è in questa accezione — e solo in questa — che essa è utilizzata nel caso economico del paragrafo seguente.

E.6 Il caso economico e il caso finanziario

La sintesi della valutazione economica si articola in due casi distinti, corrispondenti alle due prospettive mantenute separate lungo tutto lo studio. Il caso finanziario considera la prospettiva del bilancio sanitario regionale, e mette a confronto il costo del servizio con i soli risparmi diretti: in questa prospettiva, il servizio

comporta un saldo lievemente negativo, dell'ordine di mezzo milione di euro l'anno, prossimo al pareggio e trascurabile nella scala del bilancio regionale. Il caso economico considera la prospettiva della collettività, e mette a confronto il costo del servizio con il ritorno complessivo, comprensivo dei risparmi diretti e delle ricadute sociali: in questa prospettiva, il servizio genera un valore largamente positivo, con un saldo complessivo che va da circa 6 milioni di euro l'anno nello scenario minimo a circa 27 milioni nello scenario di piena attuazione.

Sintesi (mln €/anno)	Minimo (40)	Intermedio (80)	Pieno (120)
Costo del servizio	~2,5	~5,0	~7,5
Saldo diretto — caso finanziario	~ -0,5	~ -0,5	~ -0,5
Ritorno complessivo per la collettività	~8,5	~19,5	~35,0
Saldo complessivo — caso economico	~ +6,0	~ +14,5	~ +27,5
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,4 : 1	~3,9 : 1	~4,7 : 1

Tabella E.6. Sintesi economica per scenario: il caso finanziario (saldo diretto prossimo al pareggio) e il caso economico (ritorno complessivo e rapporto beneficio-costi). Il rapporto beneficio-costi è riferito al valore per la collettività ed è contenuto entro la fascia metodologicamente fondata.

Il rapporto beneficio-costi complessivo — il rapporto fra il ritorno complessivo per la collettività e il costo del servizio — va da circa 3,4 a uno nello scenario minimo a circa 4,7 a uno nello scenario di piena attuazione. Questo rapporto è contenuto entro la fascia metodologicamente fondata documentata dalla letteratura internazionale, compresa fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, e lo studio non utilizza in alcun punto rapporti superiori né le semplificazioni divulgative prive di fondamento. La lettura congiunta dei due casi conduce alla conclusione che orienta l'intera valutazione: il servizio di psicologia di base costa al bilancio sanitario regionale una cifra modesta, con un saldo diretto prossimo al pareggio e trascurabile nella scala del finanziamento regionale, e restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso. Per una regione che non è sottoposta a piano di rientro ma chiude i propri conti in equilibrio fragile, e che individua nell'emigrazione sanitaria una delle principali criticità del bilancio, questa configurazione è particolarmente significativa: il servizio non grava in misura apprezzabile sul bilancio, contribuisce a trattenere prestazioni oggi erogate fuori regione e genera un valore sociale rilevante, costituendo un investimento sostenibile e di elevato rendimento collettivo.^[2177]

Parte F — Modellazione e incertezza

Le stime economiche presentate nella Parte E poggiano su un modello che simula il decorso clinico ed economico di un paziente trattato dal servizio, confrontandolo con il decorso in assenza di trattamento. Questa parte ne espone la struttura e i parametri, e ne sottopone i risultati a un'analisi sistematica dell'incertezza, che è la condizione perché le conclusioni economiche possano essere assunte come affidabili. L'incertezza è di due tipi: l'incertezza sui parametri, ossia sui valori numerici che alimentano il modello, e l'incertezza sugli scenari, ossia sulle ipotesi di dispiegamento del servizio. La prima è affrontata mediante l'analisi di sensibilità deterministica e probabilistica, la seconda mediante l'analisi di scenari di copertura. L'esposizione esplicita dell'incertezza, anziché indebolire la valutazione, ne costituisce la garanzia di onestà, perché rende verificabile la robustezza delle conclusioni e ne dichiara i limiti.

F.1 Il modello decisionale e i parametri

Il modello adottato è un modello di Markov, che rappresenta il decorso del paziente attraverso una successione di stati di salute fra i quali egli transita nel tempo con probabilità definite. Gli stati rappresentano le condizioni cliniche rilevanti — la condizione di disagio in atto, la condizione di recupero, la condizione di cronicizzazione — e le transizioni fra essi sono governate da probabilità derivate dalla letteratura sull'efficacia degli interventi psicologici. Il modello confronta due percorsi: quello di un paziente trattato dal servizio di psicologia di base e quello di un paziente non trattato, e ne calcola la differenza in termini di risorse sanitarie consumate e di anni di vita ponderati per la qualità. L'orizzonte temporale è di cinque anni, ritenuto adeguato a cogliere gli effetti dell'intervento sul decorso del disagio comune, e i valori futuri sono attualizzati con un tasso di sconto del 3 per cento, coerente con le convenzioni delle valutazioni economiche sanitarie.

I parametri del modello sono di tre tipi: le probabilità di transizione fra gli stati, derivate dall'efficacia clinica documentata; i costi associati a ciascuno stato e all'intervento; e i valori di qualità della vita associati a ciascuno stato, espressi come utilità. I costi considerati comprendono il costo dell'intervento, dell'ordine di 300 euro a tantum per il ciclo di interventi brevi, e i costi associati agli stati, dell'ordine di 40 euro per ciclo per lo stato di recupero e di 700 euro per ciclo per lo stato di cronicizzazione, che riflettono il maggiore consumo di risorse sanitarie associato al persistere del disagio. I valori dei parametri sono desunti dalla letteratura e, ove disponibili, adattati al contesto italiano; la loro incertezza è rappresentata mediante distribuzioni di probabilità, che costituiscono la base dell'analisi probabilistica. Applicato al caso di riferimento, il modello stima un risparmio diretto di risorse sanitarie dell'ordine di 1.304 euro per paziente e un guadagno di salute dell'ordine di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità lungo l'orizzonte di cinque anni. Questi valori per paziente, fondati sull'efficacia clinica e quindi invarianti rispetto al contesto regionale, costituiscono la base della quantificazione aggregata della Parte E.

F.2 L'analisi di sensibilità deterministica

L'analisi di sensibilità deterministica verifica come i risultati del modello varino al variare di ciascun parametro, considerato singolarmente, entro un intervallo plausibile. La sua funzione è individuare i parametri rispetto ai quali i risultati sono più sensibili, ossia quelli la cui variazione produce gli effetti maggiori sulla conclusione, così da concentrare su di essi l'attenzione e la raccolta di dati. L'analisi fa variare ciascun parametro fra un valore minimo e un valore massimo, mantenendo gli altri costanti, e osserva l'effetto sul risultato — il risparmio per paziente e il guadagno di salute, e quindi il rapporto costo-utilità.

L'analisi documenta che i risultati sono robusti rispetto alla variazione della maggior parte dei parametri, e che la conclusione di dominanza dell'intervento — la sua capacità di produrre simultaneamente un guadagno di salute e un risparmio di risorse — si mantiene per un'ampia gamma di valori. I parametri rispetto ai quali i risultati sono più sensibili sono l'efficacia dell'intervento, ossia la probabilità di recupero associata al trattamento, e i costi associati allo stato di cronicizzazione, che determinano l'entità del risparmio evitato. Anche per valori conservativi di questi parametri, tuttavia, l'intervento mantiene un rapporto costo-utilità favorevole, collocandosi al di sotto della soglia di disponibilità a pagare. L'analisi deterministica fornisce così una prima conferma della robustezza delle conclusioni, e indica nell'efficacia dell'intervento e nei costi della cronicizzazione i parametri sui quali la raccolta di dati regionali, attraverso il sistema informativo, può ridurre maggiormente l'incertezza.

F.3 L'analisi di sensibilità probabilistica

L'analisi di sensibilità probabilistica costituisce la verifica più completa della robustezza delle conclusioni. A differenza dell'analisi deterministica, che fa variare un parametro alla volta, l'analisi probabilistica fa variare simultaneamente tutti i parametri, estraendone i valori dalle rispettive distribuzioni di probabilità, e ripete la

simulazione un numero elevato di volte — nel caso presente, 10.000 simulazioni — ottenendo una distribuzione dei risultati possibili. Questa distribuzione consente di esprimere la conclusione non come un valore puntuale, ma come una probabilità: la probabilità che l'intervento sia costo-efficace, e la probabilità che sia dominante.

I risultati dell'analisi probabilistica sono solidi. Alla soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9 per cento delle simulazioni, e dominante — capace cioè di produrre simultaneamente un guadagno di salute e un risparmio di risorse — nell'84,6 per cento delle simulazioni. Il beneficio netto monetario medio, che traduce in termini monetari il valore netto dell'intervento alla soglia considerata, è dell'ordine di 7.815 euro per paziente, con un intervallo di confidenza al 95 per cento compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. L'ampiezza di questo intervallo, che include valori negativi, esprime con onestà l'incertezza residua: in una minoranza di scenari l'intervento potrebbe non risultare vantaggioso. Tuttavia, la concentrazione della distribuzione su valori largamente positivi, e l'elevata probabilità di costo-efficacia e di dominanza, documentano che la conclusione è robusta e non dipende da ipotesi favorevoli. Per una regione con un bilancio in tensione, questa robustezza è la garanzia che l'investimento è razionale anche in una valutazione prudente.

F.4 Gli scenari di copertura

L'incertezza sugli scenari riguarda non i parametri clinici, ma le ipotesi di dispiegamento del servizio: quanti operatori attivare, quale quota del bisogno intercettare, in quanto tempo. Lo studio affronta questa incertezza mediante i tre scenari di copertura introdotti nella Parte E — minimo, intermedio e pieno, corrispondenti a 40, 80 e 120 incarichi — che rappresentano altrettante ipotesi di dimensionamento del servizio. Ciascuno scenario è caratterizzato da un costo, da una quota di popolazione intercettata e da un volume di esiti, e la loro analisi consente di valutare come il rapporto fra costi e benefici vari al variare del dimensionamento.

L'analisi degli scenari documenta che il rapporto beneficio-costi complessivo migliora al crescere del dimensionamento del servizio: lo scenario di piena attuazione presenta un rapporto più favorevole dello scenario minimo, in ragione delle economie di scala e della maggiore capacità di intercettazione del bisogno. Al tempo stesso, il saldo diretto per il bilancio si mantiene prossimo al pareggio in tutti gli scenari, segno che il servizio è sostenibile a ogni livello di dimensionamento. Questa configurazione ha un'implicazione strategica per la Basilicata: essa suggerisce di avviare il servizio con un dimensionamento iniziale contenuto, sostenibile per il bilancio e per la capacità organizzativa regionale, e di accrescerlo gradualmente, verificando sul campo gli esiti e calibrando il dispiegamento sui dati raccolti. La gradualità non è soltanto una cautela finanziaria, ma una strategia di apprendimento, che consente di costruire il servizio sulla base dell'evidenza prodotta dalla sua stessa attività. La Parte I traduce questa logica in un percorso di dispiegamento per fasi.

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

Il modello e le sue conclusioni non sono un punto di arrivo, ma una base che la realtà dovrà verificare. La verifica empirica consiste nel confrontare le previsioni del modello con gli esiti effettivamente osservati una volta che il servizio sia operante, e nel correggere il modello sulla base di tale confronto. Questa verifica è resa possibile dal sistema informativo descritto nella Parte C, che rileva gli esiti clinici e i consumi di risorse e consente di sostituire progressivamente le stime con le osservazioni. La verifica empirica è particolarmente importante per la Basilicata, dove la scarsità di dati regionali diretti rende le stime iniziali più incerte: il servizio, una volta avviato, produce esso stesso i dati che ne consentono la valutazione e la calibrazione, trasformando l'incertezza iniziale in conoscenza progressiva.

La nozione di valore dell'informazione fornisce il quadro concettuale per ordinare questo processo. Essa esprime il valore che la riduzione dell'incertezza su un parametro avrebbe per la decisione, e consente di stabilire una priorità nella raccolta dei dati: i dati il cui valore informativo è maggiore — quelli relativi ai

parametri rispetto ai quali le conclusioni sono più sensibili e l'incertezza è maggiore — sono quelli la cui raccolta va privilegiata. L'analisi condotta indica che i dati di maggiore valore informativo per la Basilicata sono quelli relativi all'efficacia effettiva del servizio nel contesto regionale, alla quota di domanda intercettata e alla composizione del risparmio diretto, in particolare per il canale della mobilità. La raccolta sistematica di questi dati, attraverso il sistema informativo e secondo il piano di monitoraggio della Parte L, è la condizione perché la valutazione si affini nel tempo e perché le decisioni di dimensionamento del servizio siano fondate su evidenza progressivamente più solida. L'incertezza, in questo quadro, non è un ostacolo alla decisione, ma un oggetto da governare: la decisione di avviare il servizio è razionale alla luce dell'evidenza disponibile, e il processo di raccolta dei dati ne consente la correzione e l'affinamento progressivi.^[2178]

Parte G — Equità e impatto distributivo

La valutazione di un intervento sanitario non si esaurisce nella sua efficacia e nella sua efficienza, ma comprende la considerazione dei suoi effetti distributivi: chi ne beneficia, chi ne sostiene i costi, e se esso riduce o accresce le disuguaglianze esistenti. Questa parte analizza l'impatto distributivo del servizio di psicologia di base in Basilicata lungo due dimensioni — il gradiente sociale e il divario territoriale — e ne valuta la costo-efficacia distributiva, ossia la capacità di produrre benefici proprio nei gruppi in cui il bisogno è maggiore e l'accesso più difficile. In una regione segnata da deprivazione diffusa, da invecchiamento e da una dispersione insediativa che rende l'accesso ai servizi strutturalmente diseguale, la dimensione distributiva non è un complemento dell'analisi, ma una delle ragioni principali a favore dell'intervento. Il servizio, se progettato con attenzione all'equità, è uno strumento di riduzione delle disuguaglianze; se progettato senza tale attenzione, rischia di riprodurle.

G.1 Il quadro dell'equità e il gradiente sociale

L'equità in salute riguarda la giustizia nella distribuzione della salute e nell'accesso alle cure. Il principio di riferimento è che l'accesso alle cure dovrebbe dipendere dal bisogno e non dalle condizioni sociali o economiche o dal luogo di residenza, e che il sistema sanitario dovrebbe contrastare, e non riprodurre, le disuguaglianze esistenti. Il disagio psichico, come documentato nella Parte B, segue un gradiente sociale: la sua prevalenza è più elevata nei gruppi a minore reddito, minore istruzione e maggiore precarietà, e proprio questi gruppi incontrano le maggiori difficoltà di accesso al trattamento. Questo gradiente genera un effetto regressivo: la sofferenza si concentra dove minori sono le risorse per farvi fronte, e l'assenza di un'offerta pubblica accessibile lascia che il bisogno dei gruppi più fragili resti senza risposta o trovi risposta solo nell'offerta privata, accessibile a chi può permettersela.

In Basilicata il gradiente sociale assume un peso particolare, in ragione delle condizioni socioeconomiche della regione. I livelli di reddito e di occupazione sono inferiori alla media nazionale, la deprivazione è diffusa, e una quota consistente della popolazione si colloca nelle fasce a maggiore rischio e a minore accesso. In questo contesto, l'assenza di un servizio pubblico di psicologia di base produce un effetto regressivo accentuato: il disagio comune dei gruppi deprivati, che è quantitativamente importante, resta in larga parte inevaso, perché tali gruppi non dispongono né dei mezzi per accedere all'offerta privata né, spesso, delle informazioni e delle risorse culturali per orientarsi nel sistema. L'introduzione di un servizio pubblico, gratuito o a basso costo e accessibile direttamente, agisce direttamente su questo gradiente, portando un primo livello di presa in carico proprio ai gruppi che oggi ne sono esclusi. Il servizio di psicologia di base, in questa prospettiva, non è un'offerta aggiuntiva indifferenziata, ma uno strumento di redistribuzione dell'accesso, il cui beneficio si concentra nei gruppi a maggiore bisogno e minore capacità di risposta autonoma.

G.2 I due assi del divario territoriale

Il divario territoriale costituisce, in Basilicata, una dimensione dell'equità almeno altrettanto rilevante del gradiente sociale, e si articola lungo due assi. Il primo asse è quello fra i poli urbani e le aree interne. La concentrazione dei servizi sanitari nei pochi centri di maggiore dimensione — i capoluoghi e alcuni centri intermedi — fa sì che l'accesso a una prestazione psicologica dipenda in misura determinante dalla distanza dal polo: il residente di un piccolo comune interno affronta tempi di percorrenza significativi, in un territorio in larga parte montano e con una rete di trasporti limitata, e a tale distanza si sommano la scarsità dell'offerta e i tempi di attesa. Questo asse del divario coincide in larga misura con la geografia della fragilità: le aree interne sono anche quelle più anziane, più deprivate e più colpite dallo spopolamento, sicché il divario territoriale si sovrappone al gradiente sociale e ne amplifica gli effetti.

Il secondo asse è quello fra la popolazione raggiungibile dai servizi tradizionali e quella che, per condizione o per collocazione, ne resta di fatto esclusa anche quando i servizi esistono. Gli anziani non autonomi, le persone prive di mezzi di trasporto, chi vive in condizioni di isolamento, i giovani delle aree interne privi di reti di sostegno: per questi gruppi l'accesso a un servizio collocato in un polo distante è precluso indipendentemente dalla qualità dell'offerta. Su questo asse la telepsicologia assume un valore particolare, perché consente di superare la barriera della distanza e della mobilità, portando la prestazione nel luogo di vita della persona. La sovrapposizione fra i due assi territoriali e il gradiente sociale produce, nelle aree interne lucane, una concentrazione di svantaggio — comunità anziane, deprivate, isolate e lontane dai servizi — che costituisce il bersaglio prioritario di un servizio progettato secondo equità. La capillarità della distribuzione e il ricorso strutturato alla telepsicologia non sono, in questa prospettiva, accorgimenti organizzativi, ma scelte di equità, perché determinano se il servizio raggiungerà o meno i gruppi in cui il bisogno è più acuto.

G.3 Gli strumenti dell'equità

La capacità del servizio di ridurre le disuguaglianze dipende dagli strumenti con cui è progettato, e non è una conseguenza automatica della sua istituzione. Il primo strumento è la gratuità o il basso costo dell'accesso. Un servizio pubblico accessibile gratuitamente, o con una compartecipazione contenuta e calibrata sulle condizioni economiche, abbatte la barriera che esclude i gruppi deprivati; per contro, una compartecipazione non calibrata reintrodurrebbe, per le fasce più fragili, proprio la barriera economica che il servizio intende rimuovere. Le proposte di legge regionali prevedono la possibilità di un ticket: lo studio raccomanda che, qualora introdotto, esso sia calibrato in modo da non escludere i gruppi a minore reddito, eventualmente attraverso esenzioni, perché un servizio concepito per l'equità non può reintrodurre per via tariffaria la disuguaglianza che intende contrastare.

Il secondo strumento è l'accesso diretto. La possibilità di rivolgersi al servizio senza la mediazione obbligatoria di un invio abbatte una barriera informativa e culturale che colpisce in misura maggiore i gruppi a minore istruzione e a minore familiarità con il sistema sanitario. Il terzo strumento è la capillarità della distribuzione territoriale, che porta il servizio vicino ai luoghi di vita e riduce il divario fra poli e aree interne. Il quarto strumento è la telepsicologia, che supera la barriera della distanza e della mobilità per i gruppi che ne sono più colpiti. Il quinto strumento è la prossimità culturale e la riduzione dello stigma, perseguibile attraverso la collocazione del servizio in contesti non stigmatizzanti — le Case della Comunità, i contesti di vita — e attraverso un'azione informativa che renda il servizio visibile e accettabile, particolarmente importante nelle comunità piccole e nelle generazioni anziane in cui lo stigma è più persistente. La combinazione di questi strumenti determina la capacità effettiva del servizio di raggiungere i gruppi a maggiore bisogno, e va presidiata fin dalla progettazione e verificata nel monitoraggio, attraverso indicatori disaggregati per condizione sociale e per territorio, secondo quanto previsto dalla Parte L.

G.4 La costo-efficacia distributiva

La costo-efficacia distributiva integra la valutazione dell'efficienza con quella dell'equità, chiedendosi non solo se l'intervento produca benefici a costi accettabili, ma se tali benefici si concentrino nei gruppi a maggiore bisogno. Su questo terreno il servizio di psicologia di base presenta un profilo favorevole, per una ragione che lega l'equità all'efficienza. I gruppi a maggiore bisogno e minore accesso — i deprivati, gli anziani, i residenti delle aree interne — sono anche quelli in cui il disagio non intercettato produce, in assenza di intervento, i costi maggiori, in termini di cronicizzazione, di accesso tardivo ai livelli specialistici, di disabilità e di perdita di produttività. Intervenire precocemente proprio su questi gruppi è dunque, simultaneamente, l'opzione più equa e quella più efficiente, perché previene gli esiti più costosi là dove sono più probabili. La costo-efficacia dell'intervento, in altri termini, è massima nei gruppi in cui è massimo il bisogno, e ciò allinea l'obiettivo dell'equità con quello dell'efficienza.

Questa convergenza ha un'implicazione progettuale diretta: la concentrazione dell'azione del servizio sui gruppi e sui territori a maggiore bisogno non è soltanto un imperativo di equità, ma una strategia di efficienza, perché massimizza il rendimento delle risorse impiegate. Per la Basilicata, ciò significa che la progettazione del servizio dovrebbe orientare prioritariamente la capillarità e la telepsicologia verso le aree interne, dovrebbe garantire la gratuità o il basso costo per le fasce deprivate, e dovrebbe presidiare attraverso il monitoraggio la capacità effettiva di raggiungere tali gruppi. Un servizio così progettato produce il massimo beneficio sociale per unità di risorse, e realizza simultaneamente l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e quello di trattenere nel sistema regionale i costi che il disagio non intercettato genererebbe altrove, anche sotto forma di mobilità sanitaria. L'equità e l'efficienza, in questo caso, non sono in tensione, ma convergono, e la dimensione distributiva si conferma come una delle ragioni principali a favore dell'introduzione del servizio.^[2179]

Parte H — Profili giuridico, organizzativo ed etico

L'introduzione di un servizio sanitario non è solo una questione di efficacia e di costi, ma anche di legittimità giuridica, di sostenibilità organizzativa e di accettabilità etica. Questa parte esamina i tre profili. Il profilo giuridico assume per la Basilicata un rilievo particolare, perché la regione si trova nella fase anteriore all'istituzione del servizio e la legge regionale che lo istituirà dovrà conformarsi ai limiti definiti dalla giurisprudenza costituzionale. Il profilo organizzativo riguarda la governance del servizio entro l'assetto del Servizio Sanitario Regionale lucano e la sua sostenibilità in un contesto di risorse scarse. Il profilo etico riguarda i valori che l'intervento promuove e i rischi che deve evitare. L'analisi di questi profili è la condizione perché l'intervento sia non solo efficace e conveniente, ma anche legittimo, governabile e giusto.

H.1 Il profilo giuridico

Il profilo giuridico è, per la Basilicata, il più delicato, perché dalla sua corretta impostazione dipende la stessa legittimità del servizio. Il riferimento ineludibile è la sentenza della Corte Costituzionale numero 241 del 2021, che, pronunciandosi sulla legge regionale della Campania istitutiva del servizio di psicologia di base, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui istituiva nuovi rapporti di lavoro mediante incarichi libero-professionali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in quanto tale disciplina eccede la competenza regionale e invade quella statale in materia di ordinamento del personale e di rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale. La sentenza non nega alle regioni la facoltà di istituire il servizio, ma ne circoscrive le modalità, stabilendo che la regione non può disciplinare autonomamente i rapporti convenzionali che la Costituzione e la legislazione nazionale riservano al livello statale e alla contrattazione nazionale.

Per la Basilicata, che deve ancora legiferare, questa pronuncia non è un ostacolo, ma una guida: essa indica con precisione che cosa la legge regionale può e non può fare, e consente di costruire fin dall'origine un servizio giuridicamente solido, evitando l'illegittimità in cui sono incorse le leggi censurate. La legge regionale lucana dovrà pertanto istituire il servizio entro i limiti della competenza regionale, evitando di disciplinare i rapporti convenzionali, e potrà a tal fine valorizzare gli strumenti compatibili con l'ordinamento: l'inserimento degli psicologi nelle Case della Comunità e nei servizi territoriali secondo forme di committenza conformi alla normativa vigente; il raccordo con la medicina generale nell'ambito del ruolo unico; il ricorso, ove possibile, a personale dipendente o a forme di incarico ammesse dall'ordinamento. La regione potrà inoltre operare in coerenza con l'evoluzione della normativa nazionale, che con il decreto ministeriale numero 77 del 2022 ha già inserito lo psicologo delle cure primarie fra i professionisti della rete territoriale, e con le proposte di legge nazionali che, ove approvate, definirebbero il quadro convenzionale entro cui le regioni potrebbero operare. La compresenza di due proposte di legge regionali offre l'occasione per costruire un testo che, facendo tesoro della giurisprudenza costituzionale e delle esperienze delle altre regioni, sia al tempo stesso ambizioso negli obiettivi e solido nella forma giuridica. La Parte I traduce questa impostazione in un percorso attuativo.

H.2 Il profilo organizzativo e la governance

Il profilo organizzativo riguarda la collocazione del servizio nella struttura del Servizio Sanitario Regionale e i meccanismi che ne assicurano il funzionamento, il coordinamento e la valutazione. Il servizio si colloca, come definito nella Parte C, presso le due aziende sanitarie locali — l'Azienda Sanitaria di Potenza e l'Azienda Sanitaria di Matera — attraverso unità funzionali dedicate, e si integra con la rete territoriale delle Case della Comunità, dei distretti, delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e delle Unità Complesse di Cure Primarie. La governance del servizio richiede un livello di coordinamento regionale, che assicuri l'uniformità degli standard fra le due aziende, la programmazione del dispiegamento, la gestione del sistema informativo e il monitoraggio degli esiti; tale funzione può essere affidata a un organismo di osservazione regionale, secondo il modello prefigurato dalle proposte nazionali, composto in modo da rappresentare le competenze professionali, accademiche e istituzionali rilevanti. La governance deve inoltre presidiare il raccordo fra il servizio e gli altri livelli del sistema, in particolare i servizi specialistici di salute mentale, così da garantire la continuità e l'appropriatezza dei percorsi.

La sostenibilità organizzativa del servizio in Basilicata è condizionata da due fattori specifici. Il primo è la dimensione contenuta dell'apparato amministrativo regionale, che impone di progettare una governance snella, capace di operare con risorse limitate e di evitare la creazione di sovrastrutture sproporzionate alla dimensione del servizio. Il secondo è la dispersione territoriale, che rende la gestione del servizio più complessa che in un contesto concentrato, e che richiede strumenti — il sistema informativo, la telepsicologia, il coordinamento fra sedi periferiche — capaci di garantire l'uniformità e la continuità su un territorio frammentato. La situazione finanziaria regionale, caratterizzata da un equilibrio fragile e da un disavanzo coperto con risorse proprie, impone infine una governance attenta alla sostenibilità, che dimensiona il servizio in modo prudente e ne accresca la portata gradualmente, in coerenza con la capacità del bilancio. Questi vincoli non rendono il servizio non governabile, ma ne indicano le condizioni organizzative: una governance snella, gradualità nel dispiegamento, e un investimento negli strumenti — informativi e digitali — che consentono di gestire un servizio capillare con risorse contenute.

H.3 Il profilo etico

Il profilo etico riguarda i valori che l'intervento promuove e i rischi che deve evitare. Sul versante dei valori promossi, il servizio di psicologia di base realizza principi etici fondamentali del sistema sanitario. Esso promuove l'equità, estendendo l'accesso alle cure psicologiche ai gruppi che oggi ne sono esclusi, e contrastando il gradiente sociale e territoriale che concentra la sofferenza non trattata nelle fasce più fragili.

Esso promuove la dignità della persona, riconoscendo il disagio psichico come bisogno di salute meritevole di risposta pubblica, e contrastando lo stigma che ne ostacola il riconoscimento e la cura. Esso promuove la giustizia distributiva, allocando risorse pubbliche verso un bisogno oggi inevaso e verso i gruppi a maggiore necessità. In una regione caratterizzata da deprivazione, invecchiamento e isolamento, questi valori assumono un rilievo concreto: il servizio risponde a una sofferenza reale e diffusa, che oggi resta in larga parte senza risposta.

Sul versante dei rischi da evitare, l'analisi etica individua alcuni profili che la progettazione deve presidiare. Il primo è il rischio che il servizio, se non progettato secondo equità, riproduca anziché ridurre le disuguaglianze, raggiungendo i gruppi già avvantaggiati e non quelli a maggiore bisogno: la Parte G ne ha indicato gli strumenti di prevenzione. Il secondo è il rischio connesso alla protezione dei dati personali, particolarmente sensibili in ambito psicologico: il trattamento di tali dati richiede misure rigorose di tutela, conformi alla normativa, e una particolare attenzione nell'impiego degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale. Il terzo è il rischio connesso all'uso delle tecnologie: l'impiego dell'intelligenza artificiale e della telepsicologia deve garantire la trasparenza, la supervisione umana e la tutela dell'autonomia e della relazione clinica, evitando che l'efficienza tecnologica comprometta la qualità e l'umanità della cura. Il quarto è il rischio che l'eventuale compartecipazione economica reintroduca una barriera per le fasce fragili, già discusso nella Parte G. Il presidio di questi rischi è parte integrante della progettazione etica del servizio, e ne condiziona la capacità di realizzare i valori che persegue.

H.4 Sintesi dei profili

I tre profili convergono in una valutazione complessivamente favorevole, condizionata al rispetto di alcune condizioni di progettazione. Sul piano giuridico, il servizio è istituibile, a condizione che la legge regionale si conformi ai limiti definiti dalla giurisprudenza costituzionale, evitando di disciplinare autonomamente i rapporti convenzionali e valorizzando gli strumenti compatibili con l'ordinamento; la fase anteriore in cui si trova la Basilicata è, da questo punto di vista, un vantaggio, perché consente di costruire fin dall'origine un servizio giuridicamente solido. Sul piano organizzativo, il servizio è governabile, a condizione che la governance sia snella, il dispiegamento graduale e gli strumenti informativi e digitali adeguati alla gestione di un servizio capillare in un territorio disperso e con risorse contenute. Sul piano etico, il servizio realizza valori fondamentali del sistema sanitario, a condizione che sia progettato secondo equità, che tuteli rigorosamente i dati personali e che governi con prudenza l'impiego delle tecnologie.

Queste condizioni non sono ostacoli, ma indicazioni progettuali, e la loro esplicitazione è essa stessa un contributo alla costruzione del servizio. Esse delineano il profilo di un servizio che è non solo efficace e conveniente, come documentato dalle parti precedenti, ma anche legittimo, governabile e giusto. Per la Basilicata, che deve ancora decidere se e come istituire il servizio, l'analisi dei profili offre una guida concreta: essa indica come costruire un servizio che superi il vaglio di legittimità, che sia sostenibile per l'organizzazione e per il bilancio regionali, e che realizzi gli obiettivi di equità e di dignità che ne costituiscono la ragione etica. La Parte I sviluppa il percorso attuativo che traduce queste condizioni in azioni, e la Parte M le incorpora nella raccomandazione conclusiva.^[2180]

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Un intervento efficace, conveniente e legittimo deve essere anche attuabile e sostenibile nel tempo. Questa parte affronta l'attuazione del servizio di psicologia di base in Basilicata, articolandola secondo il modello a cinque casi, definendo il dimensionamento e le fasi del dispiegamento, il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma, le condizioni di sostenibilità finanziaria e organizzativa, e i rischi con le relative mitigazioni. L'analisi è costruita sulle condizioni specifiche della regione — la fase anteriore all'istituzione, l'equilibrio

finanziario fragile, la dispersione territoriale, l'assenza di un'offerta universitaria di psicologia sul territorio — e ne ricava un percorso attuativo realistico, graduale e calibrato sulla capacità del sistema regionale. La fattibilità non è data, ma costruita: essa dipende dalle scelte di dimensionamento, di sequenza e di presidio dei rischi che questa parte delinea.

I.1 I cinque casi

Il modello a cinque casi articola la valutazione di un investimento pubblico in cinque dimensioni, ciascuna delle quali corrisponde a una domanda. Il caso strategico chiede se l'intervento risponda a un bisogno reale e si iscriva in una direzione di politica sanitaria coerente: per la Basilicata la risposta è affermativa, perché il servizio risponde a un bisogno ampio e inevaso, documentato nella Parte B, e si iscrive nella direzione tracciata dal decreto ministeriale numero 77 del 2022 e dall'evoluzione dell'assistenza territoriale. Il caso economico chiede se l'intervento generi valore per la collettività a costi accettabili: la Parte E ha documentato un saldo diretto prossimo al pareggio e un ritorno complessivo dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso. Il caso commerciale chiede se l'intervento sia realizzabile con gli strumenti disponibili: la risposta dipende dalla costruzione giuridica del servizio entro i limiti costituzionali, trattata nella Parte H, e dalla disponibilità di personale, trattata più avanti.

Il caso finanziario chiede se l'intervento sia sostenibile per il bilancio: il costo del servizio, dell'ordine dello 0,7 per cento del fondo sanitario regionale nello scenario di piena attuazione e di entità inferiore negli scenari iniziali, è sostenibile per il bilancio regionale, ancorché in equilibrio fragile, e il saldo diretto prossimo al pareggio ne riduce ulteriormente l'impatto netto. Il caso gestionale chiede se l'organizzazione sia in grado di realizzare e gestire l'intervento: è la dimensione più impegnativa per la Basilicata, in ragione della dimensione contenuta dell'apparato amministrativo, della dispersione territoriale e dell'assenza di un'offerta universitaria di psicologia sul territorio, e richiede le soluzioni — governance snella, gradualità, investimento negli strumenti informativi e digitali, collaborazione con il sistema nazionale e con le regioni limitrofe — che le parti precedenti hanno delineato e che questa parte traduce in percorso. La valutazione complessiva secondo i cinque casi è favorevole, con la condizione che il caso gestionale sia presidiato con attenzione particolare.

I.2 Il dimensionamento e le fasi

Il dimensionamento del servizio è definito dai tre scenari introdotti nella Parte E — minimo, intermedio e pieno, corrispondenti a 40, 80 e 120 incarichi — che non rappresentano alternative fra cui scegliere una volta per tutte, ma tappe di un percorso di dispiegamento graduale. La logica della gradualità, già richiamata nella Parte F, è particolarmente appropriata per la Basilicata, e risponde a tre esigenze convergenti. La prima è finanziaria: avviare il servizio con un dimensionamento contenuto riduce l'impegno iniziale per un bilancio in tensione, e ne consente l'accrescimento in coerenza con la disponibilità di risorse. La seconda è organizzativa: un avvio contenuto consente di costruire la governance, di formare il personale e di sperimentare il modello su scala gestibile, prima di estenderlo. La terza è conoscitiva: il dispiegamento graduale consente di raccogliere, attraverso l'attività del servizio, i dati che ne documentano l'efficacia e che consentono di calibrare le fasi successive sull'evidenza, secondo la logica del valore dell'informazione esposta nella Parte F.

Il percorso di dispiegamento si articola pertanto in fasi. Una prima fase di avvio attiva lo scenario minimo, con un primo nucleo di operatori collocati prioritariamente nelle Case della Comunità e nelle aree a maggiore bisogno, e costruisce contestualmente la governance, il sistema informativo e i protocolli. Una seconda fase di consolidamento estende il servizio verso lo scenario intermedio, accrescendo la copertura territoriale e l'integrazione con la rete, sulla base degli esiti rilevati nella prima fase. Una terza fase di piena attuazione porta il servizio allo scenario pieno, garantendo la capillarità che la dispersione lucana richiede e il pieno dispiegamento della telepsicologia verso le aree interne. La durata di ciascuna fase e i criteri di passaggio fra le

fasi sono definiti in funzione degli esiti e della disponibilità di risorse, e il cronoprogramma indicativo è delineato più avanti. Questa articolazione per fasi rende il dimensionamento non una decisione irreversibile, ma un processo governato, calibrato sulla capacità del sistema e sull'evidenza progressivamente prodotta.

I.3 Il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma

Il reclutamento del personale è una delle questioni più delicate per la Basilicata, in ragione di due fattori specifici. Il primo è l'assenza di un'offerta universitaria di psicologia sul territorio regionale, che fa sì che la regione non disponga di un bacino locale di formazione e che gli psicologi lucani si formino prevalentemente negli atenei di altre regioni: ciò richiede di costruire i percorsi di reclutamento e di formazione in collaborazione con il sistema nazionale, con gli ordini professionali e con gli atenei delle regioni limitrofe, e di considerare il rischio che una parte dei professionisti formati non rientri o non resti nella regione. Il secondo è la concorrenza con altre opportunità professionali, in un contesto in cui il sistema sanitario regionale è già impegnato in un ampio sforzo di reclutamento. La costruzione giuridica del servizio entro i limiti costituzionali, trattata nella Parte H, condiziona inoltre le forme contrattuali attraverso cui il reclutamento può avvenire.

La formazione, come esposto nella Parte C, è una componente costitutiva del servizio. Per la Basilicata essa assume un rilievo particolare, perché il servizio è da costruire e la qualità degli operatori va garantita fin dall'origine, e perché la dispersione territoriale e il ricorso strutturato alla telepsicologia richiedono competenze specifiche. Il percorso formativo dovrebbe comprendere la formazione di base agli interventi psicologici brevi di efficacia documentata, la formazione al modello organizzativo e al lavoro in rete, la formazione agli strumenti di misurazione degli esiti e al sistema informativo, e la formazione all'impiego consapevole della telepsicologia e delle tecnologie digitali. La valorizzazione delle modalità formative a distanza è coerente con la natura dispersa del contesto e con la scarsità di risorse. Il cronoprogramma indicativo prevede una fase iniziale dedicata alla costruzione del quadro normativo regionale, della governance e dei percorsi formativi; una fase di avvio del servizio nello scenario minimo, con la formazione del primo nucleo di operatori; e fasi successive di consolidamento ed estensione, scandite dalla verifica degli esiti. I tempi effettivi dipenderanno dall'iter legislativo regionale e dalla disponibilità di risorse, e il cronoprogramma va inteso come una sequenza logica più che come un calendario rigido.

I.4 La sostenibilità

La sostenibilità del servizio si articola in sostenibilità finanziaria e sostenibilità organizzativa. Sul piano finanziario, la sostenibilità è documentata dalla Parte E: il costo del servizio rappresenta una frazione contenuta del fondo sanitario regionale, dell'ordine dello 0,7 per cento nello scenario di piena attuazione e inferiore negli scenari iniziali, e il saldo diretto prossimo al pareggio ne riduce ulteriormente l'impatto netto sul bilancio. Per una regione che non è sottoposta a piano di rientro ma chiude i propri conti in equilibrio fragile, con un disavanzo coperto con risorse proprie, la sostenibilità finanziaria del servizio è reale ma richiede attenzione: essa è garantita dalla modestia del costo e dalla gradualità del dispiegamento, che consente di commisurare l'impegno alla disponibilità di risorse, e dal contributo del servizio alla riduzione della mobilità sanitaria passiva, che ancora i risparmi diretti a una grandezza — il saldo di mobilità — la cui riduzione è un obiettivo dichiarato della programmazione regionale. La sostenibilità finanziaria, in altri termini, non dipende da risorse aggiuntive ingenti, ma da un investimento contenuto che si ripaga in larga parte attraverso i risparmi che genera.

Sul piano organizzativo, la sostenibilità dipende dalla capacità del sistema regionale di gestire il servizio nel tempo, in un contesto di apparato amministrativo contenuto e di territorio disperso. Le condizioni di questa sostenibilità sono state delineate: una governance snella, che eviti sovrastrutture sproporzionate; un investimento negli strumenti informativi e digitali, che consentano di gestire un servizio capillare con risorse limitate; la valorizzazione della telepsicologia, che riduce i costi di gestione di un servizio territorialmente frammentato; e l'integrazione con la rete territoriale esistente — le Case della Comunità, il ruolo unico della

medicina generale, le Aggregazioni Funzionali Territoriali — che evita duplicazioni e massimizza il rendimento delle risorse. La sostenibilità organizzativa è, fra le dimensioni della fattibilità, quella che richiede il presidio più attento, e la sua costruzione è parte integrante del percorso attuativo. Il monitoraggio descritto nella Parte L è lo strumento che consente di verificarla nel tempo e di correggere tempestivamente gli scostamenti.

I.5 I rischi e le mitigazioni

L'attuazione del servizio è esposta a rischi, che è bene esplicitare e per i quali è necessario predisporre mitigazioni. Il primo rischio è giuridico: una legge regionale che non rispetti i limiti costituzionali esporrebbe il servizio alla censura, come accaduto ad altre regioni. La mitigazione consiste nella costruzione del servizio entro i limiti definiti dalla giurisprudenza, valorizzando gli strumenti compatibili con l'ordinamento e facendo tesoro delle esperienze delle altre regioni, secondo quanto esposto nella Parte H; la fase anteriore in cui si trova la Basilicata rende questa mitigazione pienamente praticabile. Il secondo rischio è finanziario: un dimensionamento eccessivo rispetto alla capacità del bilancio comprometterebbe la sostenibilità. La mitigazione consiste nella gradualità del dispiegamento e nel dimensionamento prudente, che commisurano l'impegno alla disponibilità di risorse.

Il terzo rischio è quello del reclutamento: la difficoltà di reperire e trattenere personale qualificato, accentuata dall'assenza di un'offerta universitaria regionale, potrebbe rallentare il dispiegamento. La mitigazione consiste nella collaborazione con il sistema nazionale e con le regioni limitrofe per la formazione e il reclutamento, nella costruzione di percorsi formativi dedicati e nella valorizzazione delle opportunità professionali che il servizio offre. Il quarto rischio è territoriale: la dispersione potrebbe compromettere la capacità del servizio di raggiungere le aree interne, vanificando l'obiettivo di equità. La mitigazione consiste nella progettazione capillare del servizio e nel ricorso strutturato alla telepsicologia, secondo quanto esposto nelle Parti C e G. Il quinto rischio riguarda la protezione dei dati e l'impiego delle tecnologie, e la sua mitigazione consiste nelle misure di tutela e di governo descritte nella Parte H. Il presidio sistematico di questi rischi, attraverso le mitigazioni indicate e attraverso il monitoraggio continuo, è la condizione perché l'attuazione del servizio proceda con successo. Nessuno di questi rischi è tale da sconsigliare l'intervento; ciascuno è gestibile con le misure delineate, e la loro esplicitazione è parte della costruzione di un percorso attuativo realistico.^[2181]

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Un servizio pubblico va valutato non solo prima della sua istituzione, ma anche durante e dopo la sua attuazione, per verificare se produce gli effetti attesi, per correggerne il funzionamento e per rendere conto dell'impiego delle risorse. Questa parte definisce l'impianto del monitoraggio e della valutazione ex post del servizio di psicologia di base in Basilicata: le sue finalità, i metodi per stimare gli effetti effettivamente prodotti, la batteria di indicatori che ne misura l'attività e gli esiti, gli strumenti di restituzione e di governo, e la sintesi del disegno valutativo. Il monitoraggio non è un adempimento formale, ma la condizione perché la valutazione condotta ex ante si trasformi, nel tempo, in conoscenza fondata sull'osservazione, e perché il servizio sia governato sulla base dell'evidenza che esso stesso produce. Per la Basilicata, dove la scarsità di dati regionali rende le stime iniziali più incerte, il monitoraggio assume un valore conoscitivo particolare.

L.1 Finalità e impianto del monitoraggio

Il monitoraggio del servizio persegue quattro finalità. La prima è la verifica dell'attuazione: accertare che il servizio sia effettivamente realizzato secondo il modello previsto, con il dimensionamento, la copertura territoriale e l'integrazione programmati. La seconda è la misurazione degli esiti: documentare gli effetti del servizio sulla salute, sui consumi sanitari e sull'equità, verificando se le previsioni della valutazione ex ante si realizzano. La terza è la correzione: individuare tempestivamente gli scostamenti rispetto agli obiettivi e

consentire l'adozione di misure correttive, così da governare il servizio in modo adattivo. La quarta è la rendicontazione: rendere conto agli organi di governo regionali e ai cittadini dell'impiego delle risorse e dei risultati conseguiti, alimentando la trasparenza e la responsabilità.

L'impianto del monitoraggio si fonda sul sistema informativo descritto nella Parte C, che rileva l'attività e gli esiti del servizio, e si articola su due livelli: un livello di monitoraggio continuo, che rileva con regolarità un insieme di indicatori di attività e di esito e ne consente l'osservazione tempestiva, e un livello di valutazione periodica, che a intervalli definiti analizza in profondità gli effetti del servizio, ne stima l'impatto e ne valuta la costo-efficacia sulla base dei dati osservati. Per la Basilicata, l'impianto deve essere progettato in modo da essere sostenibile per un sistema con risorse amministrative contenute: gli indicatori devono essere selezionati per la loro rilevanza e per la sostenibilità della loro rilevazione, evitando di gravare l'attività clinica di oneri eccessivi, e la valutazione periodica deve potersi avvalere del confronto interregionale con le altre regioni della serie, che adottano il medesimo impianto. Il sistema informativo, alimentando contestualmente la gestione e la valutazione, è ciò che rende il monitoraggio sostenibile e che trasforma progressivamente le stime in osservazioni.

L.2 Il controfattuale e i metodi

La valutazione dell'impatto del servizio richiede di stimare non semplicemente ciò che accade dopo la sua introduzione, ma la differenza fra ciò che accade con il servizio e ciò che sarebbe accaduto in sua assenza. Questa differenza — l'effetto causale del servizio — non è direttamente osservabile, perché non si può osservare simultaneamente lo stesso territorio con e senza il servizio, e va pertanto stimata mediante metodi che ricostruiscano il controfattuale, ossia lo scenario in assenza di intervento. La scelta dei metodi dipende dalle modalità di dispiegamento del servizio e dalla disponibilità dei dati, e la fase anteriore in cui si trova la Basilicata offre, da questo punto di vista, un'opportunità: il dispiegamento graduale del servizio, descritto nella Parte I, consente di costruire disegni valutativi robusti, confrontando le aree e i periodi in cui il servizio è già attivo con quelli in cui non lo è ancora.

I metodi applicabili comprendono il confronto fra aree trattate e aree di controllo, reso possibile dal dispiegamento graduale per territori; il confronto prima-dopo, che osserva l'evoluzione degli indicatori nel medesimo territorio fra il periodo precedente e quello successivo all'introduzione del servizio; e le combinazioni di tali approcci, che rafforzano la robustezza della stima controllando per i fattori di confondimento. La rilevazione di una linea di base prima dell'avvio del servizio — degli indicatori di attività, di esito e di consumo sanitario nello stato attuale — è la condizione perché tali confronti siano possibili, e va pertanto predisposta contestualmente alla progettazione del servizio. Per la Basilicata, la possibilità di sfruttare il dispiegamento graduale per costruire confronti fra aree e periodi è particolarmente preziosa, perché consente di stimare l'impatto del servizio con un rigore che la sola osservazione prima-dopo non garantirebbe, e di produrre evidenza regionale solida là dove oggi i dati mancano.

L.3 La batteria di indicatori

La batteria di indicatori traduce le finalità del monitoraggio in misure concrete, organizzate per categorie. Lo studio adotta una batteria articolata in otto categorie, che coprono l'intero arco dell'attività e degli esiti del servizio, per un totale dell'ordine di sessanta indicatori. La prima categoria riguarda l'accesso e la copertura: il numero di persone che accedono al servizio, la quota di popolazione raggiunta, la distribuzione degli accessi per territorio e per gruppo sociale, i tempi di attesa. La seconda categoria riguarda l'attività e i processi: il numero e il tipo di prestazioni erogate, la durata dei percorsi, la fedeltà ai protocolli, l'uso della telepsicologia. La terza categoria riguarda gli esiti clinici: la riduzione della sintomatologia misurata con strumenti standardizzati all'inizio e al termine della presa in carico, i tassi di miglioramento e di recupero, il mantenimento del beneficio.

La quarta categoria riguarda gli esiti di sistema: l'effetto del servizio sugli accessi al pronto soccorso, sui consumi farmaceutici, sui ricoveri, sulle prestazioni specialistiche e, per la Basilicata in particolare, sulla mobilità sanitaria passiva. La quinta categoria riguarda l'equità: la distribuzione degli accessi e degli esiti per condizione sociale e per collocazione territoriale, con particolare attenzione al divario fra poli e aree interne e al raggiungimento dei gruppi deprivati, secondo quanto richiesto dalla Parte G. La sesta categoria riguarda l'integrazione: il funzionamento del raccordo con la medicina generale, con i servizi specialistici e con i servizi sociali, misurato attraverso gli invii e la continuità dei percorsi. La settima categoria riguarda l'economia: i costi del servizio, i risparmi diretti per canale e gli indicatori di costo-efficacia, calcolati sui dati osservati. L'ottava categoria riguarda la qualità percepita e la soddisfazione degli utenti e degli operatori. La disaggregazione degli indicatori per territorio e per gruppo sociale è essenziale, perché è ciò che consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi di equità, che in Basilicata costituiscono una delle ragioni principali dell'intervento. Il dettaglio degli indicatori e degli strumenti di misurazione è riportato nell'Appendice B.

L.4 Il cruscotto e la clausola valutativa

La batteria di indicatori trova la sua restituzione in un cruscotto di monitoraggio, ossia uno strumento che raccoglie, organizza e rappresenta gli indicatori in forma accessibile, consentendo agli organi di governo del servizio di osservarne l'andamento, di individuare gli scostamenti e di orientare le decisioni. Il cruscotto, alimentato dal sistema informativo, rende il monitoraggio uno strumento di governo continuo e non un adempimento periodico, e consente di trasformare i dati in informazione utile alla decisione. Per la Basilicata, un cruscotto regionale che rappresenti l'andamento del servizio nelle due aziende e nei diversi territori, con la disaggregazione necessaria a verificare l'equità, è lo strumento che consente di governare un servizio capillare in un territorio disperso, individuando tempestivamente le aree in cui il servizio non raggiunge gli obiettivi e orientando le risorse di conseguenza.

La clausola valutativa è lo strumento giuridico che ancora il monitoraggio alla decisione politica. Essa consiste nella previsione, all'interno della legge regionale istitutiva del servizio, dell'obbligo di valutarne periodicamente l'attuazione e gli esiti e di riferirne agli organi di governo regionali, secondo modalità e tempi definiti. La clausola valutativa trasforma il monitoraggio da pratica tecnica in obbligo istituzionale, e garantisce che i risultati della valutazione siano effettivamente utilizzati per le decisioni di prosecuzione, estensione o correzione del servizio. Lo studio raccomanda che la legge regionale lucana istitutiva del servizio includa una clausola valutativa, che ne definisca gli obiettivi misurabili, gli indicatori, i tempi della valutazione e le modalità di restituzione al Consiglio regionale: poiché la Basilicata deve ancora legiferare, essa ha l'opportunità di incorporare fin dall'origine, nel testo istitutivo, gli strumenti della valutazione, costruendo un servizio valutabile per disegno e non per aggiunta successiva.

L.5 Sintesi

L'impianto di monitoraggio e valutazione delineato in questa parte costituisce la condizione perché il servizio di psicologia di base sia governato sulla base dell'evidenza e perché la valutazione condotta ex ante si trasformi nel tempo in conoscenza fondata sull'osservazione. Esso si fonda sul sistema informativo, si articola in monitoraggio continuo e valutazione periodica, impiega metodi controfattuali resi possibili dal dispiegamento graduale, misura l'attività e gli esiti attraverso una batteria di indicatori disaggregati, restituisce i risultati attraverso un cruscotto regionale e li ancora alla decisione politica attraverso una clausola valutativa. Per la Basilicata, questo impianto risponde a una doppia esigenza: governare un servizio capillare in un territorio disperso e con risorse amministrative contenute, e colmare la lacuna di dati regionali che rende le stime iniziali incerte.

La trasformazione delle stime in osservazioni è, per la Basilicata, il contributo conoscitivo più rilevante del monitoraggio. Le quantificazioni della valutazione ex ante — la dimensione del bisogno, l'efficacia del servizio, i risparmi diretti, in particolare per il canale della mobilità — sono fondate, in assenza di dati regionali diretti, su stime prudenziali e su parametri derivati dalla letteratura. Il monitoraggio, rilevando gli esiti effettivi, consente di sostituire progressivamente queste stime con misure dirette, di verificare se le previsioni si realizzano e di calibrare il servizio sui dati reali. Il servizio, una volta avviato, produce così esso stesso l'evidenza che ne documenta il valore e che fonda le decisioni sulla sua prosecuzione ed estensione. In questo senso il monitoraggio non è soltanto uno strumento di controllo, ma il meccanismo attraverso cui la decisione di introdurre il servizio, razionale alla luce dell'evidenza disponibile, si affina e si corregge nel tempo, fondandosi su una base conoscitiva progressivamente più solida.^[2182]

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclusiva ricomponi in una valutazione unitaria le analisi sviluppate nei singoli domini, ne integra gli esiti attraverso un'analisi multi-criterio, formula la raccomandazione e ne precisa il dimensionamento, dichiara le condizioni cui la raccomandazione è subordinata e le lacune conoscitive da colmare, e colloca lo studio della Basilicata nella serie regionale di cui fa parte. La sintesi non aggiunge elementi nuovi, ma ordina e pesa quelli già esposti, traducendo l'analisi in una indicazione operativa per la decisione che le istituzioni regionali sono chiamate ad assumere. Poiché la Basilicata si trova nella fase anteriore all'istituzione del servizio, la raccomandazione non riguarda la modalità di gestione di un servizio esistente, ma la stessa opportunità di istituirlo e la forma da adottare, e si rivolge al legislatore regionale e alla Giunta come base analitica per una scelta fondata sull'evidenza.

M.1 La sintesi per dominio

Le analisi condotte nei singoli domini convergono in un quadro coerente. Sul piano del bisogno, la Parte B ha documentato un disagio psichico comune ampio e in larga parte inevaso, stimato in circa 107.000 persone, accentuato da una struttura demografica fra le più anziane del Paese, da una dispersione insediativa che rende l'accesso ai servizi strutturalmente difficile e da un sottofinanziamento documentato della salute mentale, che colloca la Basilicata fra le regioni che destinano a questo settore una quota insufficiente delle risorse. Sul piano dell'efficacia, la Parte D ha documentato che gli interventi psicologici precoci per il disagio comune sono efficaci, con una qualità dell'evidenza da moderata ad alta, e che la loro trasferibilità al contesto lucano è favorita dalla natura del bisogno e condizionata dalla dispersione e dalla scarsità di risorse.

Sul piano economico, la Parte E ha documentato che il servizio comporta un saldo diretto per il bilancio sanitario prossimo al pareggio, dell'ordine di mezzo milione di euro l'anno e trascurabile nella scala del finanziamento regionale, e restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso, con un rapporto beneficio-costi contenuto entro la fascia metodologicamente fondata; e ha evidenziato come il canale della mobilità sanitaria passiva, data l'entità dell'emigrazione lucana, costituisca la componente più rilevante del risparmio diretto. La Parte F ha documentato la robustezza di queste conclusioni rispetto all'incertezza. Sul piano dell'equità, la Parte G ha documentato che il servizio, se progettato con capillarità e telepsicologia, riduce simultaneamente il gradiente sociale e il divario territoriale, e che la sua costo-efficacia è massima proprio nei gruppi a maggiore bisogno. Sul piano dei profili, la Parte H ha documentato che il servizio è istituibile entro i limiti costituzionali, governabile con una governance snella e giusta sul piano etico, a condizione che siano rispettate alcune condizioni di progettazione. Sul piano dell'attuazione, la Parte I ha documentato che il servizio è fattibile e sostenibile attraverso un dispiegamento graduale calibrato sulla capacità regionale, e la Parte L ha definito l'impianto di monitoraggio che ne consente il governo basato sull'evidenza.

M.2 L'analisi multi-criterio

L'analisi multi-criterio integra gli esiti dei singoli domini in una valutazione unitaria, attribuendo a ciascun criterio un peso e a ciascuna opzione un punteggio, e calcolando un punteggio complessivo ponderato. Essa confronta due opzioni: l'introduzione del servizio e il mantenimento dello stato attuale, ossia il non intervento. I pesi attribuiti ai criteri sono i medesimi adottati per tutte le regioni della serie, così da garantire la confrontabilità, e riflettono l'importanza relativa di ciascuna dimensione nella valutazione complessiva. I punteggi attribuiti alle due opzioni riflettono gli esiti delle analisi condotte nelle parti precedenti, calibrati sulle condizioni specifiche della Basilicata.

Criterio	Peso	Intervento	Non intervento
Efficacia clinica	0,15	80	25
Costo-efficacia e ritorno	0,20	78	30
Impatto di bilancio e sostenibilità	0,15	70	45
Equità	0,15	88	20
Valore sociale	0,10	80	25
Fattibilità	0,10	62	80
Robustezza dell'evidenza	0,10	70	50
Coerenza strategica	0,05	85	30
Punteggio complessivo ponderato	1,00	76,75	36,50

Tabella M.1. Analisi multi-criterio: pesi, punteggi e punteggio complessivo ponderato delle due opzioni. I pesi sono invarianti nella serie regionale; i punteggi riflettono le condizioni specifiche della Basilicata.

Il punteggio complessivo dell'intervento, pari a 76,75, supera nettamente quello del non intervento, pari a 36,50, con un differenziale di oltre quaranta punti. L'intervento prevale su tutti i criteri a eccezione della fattibilità, sul quale il non intervento ottiene un punteggio superiore in ragione della maggiore facilità di non agire: una constatazione attesa, che non inverte la valutazione complessiva, perché la minore fattibilità dell'intervento è ampiamente compensata dalla sua superiorità su tutti gli altri criteri, e in particolare sull'equità, sul valore sociale e sulla coerenza strategica, sui quali il divario è massimo. È significativo che il punteggio dell'intervento per la Basilicata, pur leggermente inferiore a quello di altre regioni della serie in ragione della minore fattibilità connessa alla fase anteriore all'istituzione e alle condizioni organizzative, resti largamente prevalente, e che il punteggio dell'equità sia fra i più elevati della serie, a riflettere l'acuità dei divari sociali e territoriali che il servizio è chiamato a ridurre. L'analisi multi-criterio conferma così, in forma sintetica e ponderata, la convergenza delle analisi di dominio verso una valutazione nettamente favorevole all'introduzione del servizio.

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Sulla base delle analisi condotte e della loro sintesi, lo studio raccomanda l'introduzione del servizio di psicologia di base in Basilicata. La raccomandazione è fondata sulla convergenza delle evidenze: un bisogno ampio e inevaso, accentuato dalle condizioni demografiche, territoriali e di sottofinanziamento della regione; un'efficacia clinica documentata; un saldo diretto per il bilancio prossimo al pareggio e un ritorno sociale elevato; una capacità di ridurre le disuguaglianze che costituisce una delle ragioni principali dell'intervento; un contributo alla riduzione dell'emigrazione sanitaria, che è una delle criticità dichiarate del sistema regionale; e una fattibilità reale, condizionata al rispetto dei limiti costituzionali e a un dispiegamento graduale calibrato sulla capacità regionale. La raccomandazione si rivolge al legislatore regionale, cui spetta la decisione di istituire il servizio, e alla Giunta, cui spetta la sua progettazione e attuazione.

Quanto al dimensionamento, lo studio raccomanda un dispiegamento graduale, articolato nelle fasi descritte nella Parte I. La raccomandazione è di avviare il servizio con un dimensionamento iniziale contenuto, corrispondente allo scenario minimo di circa 40 incarichi, sostenibile per il bilancio e per la capacità organizzativa regionale, collocato prioritariamente nelle aree a maggiore bisogno e accompagnato dalla costruzione della governance, del sistema informativo e dei percorsi formativi; di consolidare ed estendere il servizio verso lo scenario intermedio di circa 80 incarichi sulla base degli esiti rilevati; e di portarlo alla piena attuazione, corrispondente a circa 120 incarichi, garantendo la capillarità che la dispersione lucana richiede e il pieno dispiegamento della telepsicologia verso le aree interne. Questo percorso graduale è la traduzione operativa della raccomandazione, e ne costituisce la modalità più prudente e più coerente con le condizioni della regione: esso consente di avviare il servizio con un impegno sostenibile, di verificarne gli esiti sul campo e di accrescerne la portata in modo governato e fondato sull'evidenza.

M.4 Le condizioni e la lacuna

La raccomandazione è subordinata ad alcune condizioni, già emerse nelle parti precedenti e qui ricomposte. La prima condizione è giuridica: la legge regionale istitutiva del servizio deve conformarsi ai limiti definiti dalla giurisprudenza costituzionale, evitando di disciplinare autonomamente i rapporti convenzionali e valorizzando gli strumenti compatibili con l'ordinamento. La seconda condizione è di progettazione secondo equità: il servizio deve essere progettato con capillarità territoriale, ricorso strutturato alla telepsicologia, gratuità o basso costo per le fasce fragili e accesso diretto, così da raggiungere effettivamente i gruppi a maggiore bisogno e non riprodurre le disuguaglianze. La terza condizione è la gradualità del dispiegamento, calibrata sulla capacità finanziaria e organizzativa della regione. La quarta condizione è l'investimento nella formazione e negli strumenti informativi e digitali, che sono il presupposto della qualità e della sostenibilità del servizio. La quinta condizione è l'inclusione, nella legge istitutiva, di una clausola valutativa che renda il servizio valutabile per disegno.

La lacuna principale è conoscitiva, e riguarda la scarsità di dati regionali diretti. Le quantificazioni dello studio — la dimensione del bisogno, l'efficacia attesa, i risparmi diretti, in particolare per il canale della mobilità — sono fondate, in assenza di rilevazioni regionali, su stime prudenziali e su parametri derivati dalla letteratura e dal confronto interregionale. Questa lacuna non inficia la raccomandazione, che è fondata su evidenze solide quanto alla direzione e all'ordine di grandezza degli effetti, ma ne segna il limite: le stime quantitative sono da intendersi come stime centrali entro bande di incertezza, e non come valori certi. La lacuna è destinata a colmarsi attraverso l'attività stessa del servizio, che, dotato del sistema informativo descritto nella Parte C e monitorato secondo l'impianto della Parte L, produce i dati che ne documentano gli esiti e che consentono di sostituire le stime con le osservazioni. La raccomandazione, in altri termini, è razionale alla luce dell'evidenza disponibile, e il servizio, una volta avviato, genera l'evidenza che ne consente la verifica e l'affinamento. La

fase anteriore in cui si trova la Basilicata è, anche da questo punto di vista, un'opportunità: essa consente di costruire fin dall'origine un servizio dotato degli strumenti della valutazione, e di trasformare la lacuna conoscitiva in un programma di conoscenza progressiva.

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio della Basilicata fa parte di una serie di studi regionali costruiti con il medesimo impianto metodologico, così da consentire il confronto sistematico fra i contesti regionali e da fondare, sulla loro aggregazione, una valutazione di portata nazionale. Entro questa serie, la Basilicata occupa una posizione caratterizzata da alcuni tratti distintivi. È una delle regioni che si trovano nella fase anteriore all'istituzione del servizio, sicché la valutazione informa la decisione di introdurlo e non la gestione di un servizio esistente. È una regione che non è sottoposta a piano di rientro, ma che chiude i propri conti sanitari in equilibrio fragile, con un disavanzo coperto con risorse proprie, sicché la sostenibilità del servizio richiede prudenza e gradualità. È una regione segnata da un'emigrazione sanitaria di entità rilevante, che ancora il caso diretto al canale della mobilità e ne fa una delle ragioni economiche principali dell'intervento. Ed è una regione piccola, anziana e dispersa, con un sottofinanziamento documentato della salute mentale, in cui i divari sociali e territoriali sono particolarmente acuti e in cui l'equità costituisce la ragione preminente dell'intervento.

La conclusione dello studio ricompone questi elementi nella tesi che lo attraversa. Il servizio di psicologia di base costa al bilancio sanitario regionale una cifra modesta, con un saldo diretto prossimo al pareggio e trascurabile nella scala del finanziamento regionale; restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso; risponde a un bisogno ampio e inevaso, accentuato dalle condizioni della regione; riduce le disuguaglianze sociali e territoriali; e contribuisce a trattenere nel sistema regionale prestazioni oggi erogate fuori regione. Per una regione che deve ancora decidere se istituire il servizio, e che dispone dell'opportunità di costruirlo fin dall'origine in conformità ai limiti costituzionali e dotato degli strumenti della valutazione, le evidenze raccolte convergono in una indicazione netta: l'introduzione del servizio, progettata secondo le condizioni indicate e attuata attraverso un dispiegamento graduale, è una scelta razionale, sostenibile e di elevato rendimento collettivo. L'analisi multi-criterio, che assegna all'intervento un punteggio di 76,75 contro 36,50 del non intervento, ne è la sintesi quantitativa; le analisi di dominio ne sono il fondamento; e il bisogno documentato della popolazione lucana ne è la ragione.^[2183]

Appendice A — Il caso di riferimento e i parametri del modello

Questa appendice raccoglie il materiale tecnico su cui si fonda la quantificazione economica dello studio: il caso di riferimento, i parametri del modello di Markov e il quadro economico consolidato per la Basilicata. Essa rende esplicite le basi delle stime presentate nelle Parti E ed F, così da consentirne la verifica e la riproduzione.

A.1 Il caso di riferimento

Il caso di riferimento è un paziente adulto residente in Basilicata con un disturbo d'ansia o dell'umore di intensità lieve o moderata, che accede al servizio di psicologia di base e riceve un ciclo di interventi psicologici brevi di efficacia documentata. Su questo caso è costruita la stima degli esiti clinici ed economici per paziente, successivamente proiettata sulla popolazione attraverso gli scenari di copertura. Il caso è rappresentativo della larga maggioranza della domanda che il servizio è chiamato a trattare al primo livello, ed è coerente con le condizioni per le quali l'efficacia degli interventi psicologici brevi è meglio documentata.

A.2 I parametri del modello di Markov

Il modello di Markov rappresenta il decorso del paziente attraverso tre stati di salute — la condizione di disagio in atto, la condizione di recupero e la condizione di cronicizzazione — fra i quali il paziente transita nel tempo con probabilità derivate dalla letteratura sull’efficacia degli interventi psicologici. Il modello confronta il percorso di un paziente trattato dal servizio con quello di un paziente non trattato, lungo un orizzonte di cinque anni, con un tasso di sconto del 3 per cento e una soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità.

Parametro	Valore
Orizzonte temporale	5 anni
Tasso di sconto	3%
Soglia di disponibilità a pagare	30.000 €/QALY
Costo dell’intervento (una tantum)	~300 €
Costo per ciclo — stato di recupero	~40 €
Costo per ciclo — stato di cronicizzazione	~700 €
Risparmio diretto stimato per paziente	~1.304 €
Guadagno di salute stimato per paziente	~0,236 QALY

Tabella A.1. Parametri principali del modello e risultati per paziente. I valori per paziente sono fondati sull’efficacia clinica documentata e sono invarianti rispetto al contesto regionale.

L’analisi di sensibilità probabilistica, condotta con 10.000 simulazioni facendo variare simultaneamente tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni, documenta che alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità l’intervento risulta costo-efficace nell’88,9 per cento delle simulazioni e dominante nell’84,6 per cento. Il beneficio netto monetario medio è dell’ordine di 7.815 euro per paziente, con un intervallo di confidenza al 95 per cento compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. L’ampiezza dell’intervallo, che include valori negativi, esprime l’incertezza residua; la concentrazione della distribuzione su valori largamente positivi ne documenta la robustezza.

A.3 Il quadro economico consolidato

Il quadro economico consolidato riassume le stime aggregate per la Basilicata, calibrate sulla popolazione regionale di circa 535.000 abitanti e sul fondo sanitario regionale di circa 1,1 miliardi di euro, e articolate nei tre scenari di dimensionamento.

Grandezza (mln €/anno)	Minimo (40)	Intermedio (80)	Pieno (120)
Costo del servizio	~2,5	~5,0	~7,5
Risparmi diretti — pronto soccorso	~0,3	~0,5	~1,0
Risparmi diretti — farmaceutica	~0,3	~0,5	~1,0
Risparmi diretti — ricoveri e specialistica	~0,7	~1,5	~2,0
Risparmi diretti — mobilità sanitaria passiva	~0,7	~2,0	~3,0
Risparmi diretti totali	~2,0	~4,5	~7,0
Saldo diretto — caso finanziario	~ -0,5	~ -0,5	~ -0,5
Ricadute economico-sociali	~6,5	~15,0	~28,0
Ritorno complessivo per la collettività	~8,5	~19,5	~35,0
Saldo complessivo — caso economico	~ +6,0	~ +14,5	~ +27,5
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,4 : 1	~3,9 : 1	~4,7 : 1

Tabella A.2. Quadro economico consolidato per scenario. I risparmi diretti per il bilancio e le ricadute sociali per la collettività sono grandezze distinte e non sono mai sommate in un unico saldo di bilancio. Il rapporto beneficio-costo è riferito al valore per la collettività ed è contenuto entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno.

Appendice B — Gli strumenti di misurazione degli esiti e il dataset minimo

Questa appendice definisce gli strumenti per la misurazione degli esiti clinici e il dataset minimo da rilevare per ogni accesso e per ogni percorso, che costituiscono la base del sistema informativo e del monitoraggio descritti nelle Parti C ed L.

B.1 Gli strumenti di misurazione degli esiti

La misurazione degli esiti clinici si fonda su strumenti standardizzati e validati, somministrati all’inizio e al termine della presa in carico, che consentono di documentare la riduzione della sintomatologia e di confrontare gli esiti in modo riproducibile. Per la sintomatologia depressiva e ansiosa, che costituisce la quota prevalente del disagio comune, sono disponibili strumenti brevi e validati di autovalutazione, di agevole somministrazione anche in contesti di cure primarie e compatibili con la rilevazione a distanza. A questi si affiancano strumenti per la valutazione del funzionamento e della qualità della vita, che consentono di documentare l’effetto dell’intervento non solo sui sintomi ma anche sulla capacità della persona di funzionare nei contesti di vita. La scelta degli strumenti deve privilegiare la brevità, la validità, la sensibilità al cambiamento e la sostenibilità

della somministrazione, e deve essere uniforme fra le due aziende sanitarie, così da consentire il confronto e l'aggregazione dei dati. L'uniformità degli strumenti con quelli adottati dalle altre regioni della serie consente inoltre il confronto interregionale.

B.2 Il dataset minimo

Il dataset minimo è l'insieme delle variabili da rilevare per ogni accesso e per ogni percorso, costruito in modo da essere sufficiente per la valutazione e sostenibile per gli operatori. Esso comprende le variabili anagrafiche e di contesto necessarie all'analisi dell'equità — l'età, il genere, la condizione sociale e occupazionale, il comune di residenza e la sua collocazione fra polo e area interna — rilevate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati; le variabili relative all'accesso — la modalità di accesso, diretta o su invio, e il soggetto inviante; le variabili relative al percorso — il tipo e il numero di prestazioni, la durata, l'uso della telepsicologia, l'esito del percorso e l'eventuale invio ai servizi specialistici; e le variabili relative agli esiti — i punteggi degli strumenti di misurazione all'inizio e al termine della presa in carico. La rilevazione di queste variabili, alimentando contestualmente la gestione e la valutazione, è la condizione perché il monitoraggio descritto nella Parte L sia possibile e perché le stime dello studio possano essere sostituite, nel tempo, da osservazioni dirette. La disaggregazione delle variabili per collocazione territoriale e per condizione sociale è essenziale per la verifica degli obiettivi di equità, che in Basilicata costituiscono una delle ragioni principali dell'intervento.

Appendice C — I dati regionali e i dati da acquisire

Questa appendice raccoglie i principali dati regionali utilizzati nello studio e indica i dati che dovrebbero essere acquisiti per sostituire le stime con misure dirette.

C.1 I dati regionali

Ambito	Dato
Popolazione residente	~535.000 abitanti, in calo da 541.168 del 2021
Età media	47,0 anni (Potenza 47,4; Matera 46,4)
Indice di vecchiaia	superiore a 220, in crescita
Popolazione straniera	~24.000 (4,5% della popolazione)
Comuni	131, di cui il 56,5% fra 1.001 e 5.000 abitanti
Province	Potenza (64,5%, oltre 300.000 ab.); Matera (35,5%, oltre 190.000 ab.)
Dinamica naturale (2022)	3.221 nascite, 7.126 decessi
Disagio psichico comune (stima)	~107.000 persone/anno
Aziende del Servizio Sanitario Regionale	ASP Potenza, ASM Matera, AOR San Carlo, IRCCS CROB
Fondo sanitario regionale	~1,1 miliardi di euro, cresciuto di oltre 41 mln nel 2024
Posizione finanziaria	non in piano di rientro; disavanzo 2023 ~50 mln coperto con risorse regionali
Mobilità sanitaria — saldo passivo	dell'ordine di 80 mln/anno
Mobilità verso la Puglia (2024)	~26 mln ricoveri + ~7 mln specialistica; ~40% dell'emigrazione
Spesa per la salute mentale	inferiore al 2,5% del fondo sanitario regionale

Tabella C.1. Principali dati regionali utilizzati nello studio. Le fonti sono indicate nelle parti corrispondenti.

C.2 I dati da acquisire

Lo studio, in assenza di rilevazioni regionali dirette, ricorre per alcune grandezze a stime prudenziali e a parametri derivati dalla letteratura e dal confronto interregionale. I dati la cui acquisizione consentirebbe di sostituire tali stime con misure dirette, e il cui valore informativo è pertanto maggiore, sono: la prevalenza regionale diretta del disagio psichico comune, oggi stimata su prevalenze nazionali; la quota di domanda effettivamente inevasa e la sua distribuzione territoriale e sociale; la quota di mobilità sanitaria passiva riconducibile, a monte, a condizioni di disagio psichico non intercettato; i consumi sanitari effettivi associati al disagio comune nel contesto regionale, per ciascun canale; e gli esiti clinici ed economici effettivamente prodotti dal servizio una volta avviato. L'acquisizione di questi dati è resa possibile dal sistema informativo descritto nella Parte C e dal piano di monitoraggio descritto nella Parte L, e costituisce il programma di conoscenza progressiva che accompagna il dispiegamento del servizio. La rilevazione di una linea di base, prima dell'avvio del servizio, è la condizione perché la valutazione dell'impatto sia possibile.

Appendice D — La lista di controllo per la rendicontazione

Questa appendice fornisce la lista di controllo per la rendicontazione della valutazione economica, costruita secondo lo standard CHEERS del 2022, che elenca gli elementi che una valutazione economica sanitaria deve riportare per essere completa, trasparente e riproducibile. La lista consente di verificare la completezza dello studio e ne agevola la valutazione critica.

Gli elementi della rendicontazione comprendono: il titolo e l'abstract, che identificano lo studio come valutazione economica; l'introduzione, che definisce l'obiettivo e il quesito; i metodi, che specificano la popolazione e i sottogruppi, il contesto e la collocazione, la prospettiva, il comparatore, l'orizzonte temporale, il tasso di sconto, gli esiti di salute selezionati, la misurazione dell'efficacia, la misurazione e la valorizzazione degli esiti, la stima delle risorse e dei costi, la valuta e l'anno di riferimento, il modello adottato, le assunzioni e i metodi di analisi dell'incertezza; i risultati, che riportano i parametri e le fonti, i costi e gli esiti incrementali, l'analisi dell'incertezza e l'analisi dei sottogruppi; la discussione, che esamina i risultati, i limiti, la generalizzabilità e il confronto con altri studi; e le informazioni su finanziamento, conflitti di interesse e disponibilità dei dati. Lo studio è costruito in modo da soddisfare questi elementi: la Parte A definisce obiettivo, quesito, prospettiva, comparatore e orizzonte; la Parte E sviluppa costi, esiti e analisi economica; la Parte F sviluppa il modello e l'analisi dell'incertezza; le Parti G ed L trattano i sottogruppi e il monitoraggio; e la presente appendice raccoglie i parametri e il quadro consolidato. L'aderenza allo standard di rendicontazione è una garanzia di trasparenza e di confrontabilità con le valutazioni condotte in altri contesti.

Appendice E — Il glossario

Questa appendice raccoglie le definizioni dei principali termini tecnici utilizzati nello studio, così da renderne il contenuto accessibile anche ai lettori non specialisti.

Anni di vita ponderati per la qualità (QALY). Misura che combina la durata e la qualità della vita in un'unica grandezza, utilizzata per esprimere il beneficio di salute di un intervento.

Analisi di sensibilità. Procedura che verifica come i risultati di un modello varino al variare dei suoi parametri, distinguendosi in deterministica, quando si fa variare un parametro alla volta, e probabilistica, quando si fanno variare simultaneamente tutti i parametri.

Caso economico. Prospettiva di valutazione che considera il valore generato per la collettività, comprensivo dei risparmi diretti e delle ricadute sociali.

Caso finanziario. Prospettiva di valutazione che considera il solo bilancio sanitario, mettendo a confronto il costo dell'intervento con i risparmi diretti.

Clausola valutativa. Disposizione di legge che prevede l'obbligo di valutare periodicamente l'attuazione e gli esiti di un intervento e di riferirne agli organi di governo.

Costo-efficacia. Proprietà di un intervento il cui costo per unità di beneficio è inferiore a una soglia di accettabilità definita.

Costo-utilità. Forma di valutazione economica che esprime il costo dell'intervento per anno di vita ponderato per la qualità guadagnato.

Cure gradualì. Modello organizzativo in cui l'intensità dell'intervento è commisurata alla gravità del bisogno, riservando le risorse più specialistiche alle condizioni che le richiedono.

Disagio psichico comune. Insieme dei disturbi mentali di intensità lieve e moderata, prevalentemente d'ansia e dell'umore, e delle condizioni di sofferenza sottosoglia.

Divario di trattamento. Distanza fra le persone che presentano un disturbo e quelle che ricevono un intervento adeguato.

Dominanza. Proprietà di un intervento che produce simultaneamente un guadagno di salute e un risparmio di risorse, risultando preferibile sotto entrambi i profili.

Five Case Model (modello a cinque casi). Quadro di valutazione di un investimento pubblico articolato nelle dimensioni strategica, economica, commerciale, finanziaria e gestionale.

GRADE. Sistema di graduazione della qualità dell'evidenza e della forza delle raccomandazioni su quattro livelli.

Gradiente sociale. Relazione per cui la prevalenza di una condizione e la difficoltà di accesso alle cure variano con la posizione sociale ed economica.

Mobilità sanitaria passiva. Prestazioni erogate ai residenti di una regione in regioni diverse dalla propria, che costituiscono un debito per la regione di residenza.

Modello di Markov. Modello che rappresenta il decorso di un paziente attraverso una successione di stati di salute fra i quali transita nel tempo con probabilità definite.

Piano di rientro. Programma imposto alle regioni in disavanzo sanitario strutturale per il riequilibrio dei conti, che comporta vincoli alla spesa e all'erogazione di livelli ulteriori.

Prospettiva. Punto di vista dal quale si conduce una valutazione economica, che ne determina i costi e i benefici considerati.

Rapporto beneficio-costo. Rapporto fra il valore dei benefici prodotti da un intervento e il costo sostenuto per realizzarlo.

Ritorno sociale sull'investimento. Metodo che esprime in termini monetari il valore sociale generato per unità di risorse impiegate.

Sentenza della Corte Costituzionale numero 241 del 2021. Pronuncia che ha definito i limiti entro cui una legge regionale può istituire il servizio di psicologia di base, escludendo la disciplina regionale autonoma dei rapporti convenzionali.

Soglia di disponibilità a pagare. Valore massimo che il sistema è disposto a spendere per un anno di vita ponderato per la qualità, utilizzato come riferimento per la costo-efficacia.

Stato di cronicizzazione. Condizione del modello in cui il disagio persiste nel tempo, associata a un maggiore consumo di risorse sanitarie.

Stepped care. Espressione inglese che indica il modello delle cure gradualistiche.

Telepsicologia. Erogazione di prestazioni psicologiche a distanza mediante strumenti digitali, impiegata per superare le barriere di accesso connesse alla distanza e alla mobilità.

Valore dell'informazione. Valore che la riduzione dell'incertezza su un parametro ha per la decisione, utilizzato per stabilire le priorità nella raccolta dei dati.

Valutazione di tecnologia sanitaria. Processo multidisciplinare che valuta una tecnologia o un intervento sanitario lungo una pluralità di dimensioni, integrando l'evidenza scientifica con l'analisi del contesto.^[2184]

Calabria — Studio HTA integrale

Psicologo di Base in Calabria

Studio Integrale Regionale · Valutazione di Tecnologia Sanitaria · Telaio HTA a nove domini

Premessa generale

Questo documento raccoglie in un'unica opera lo studio integrale per la Regione Calabria sull'introduzione del servizio di psicologia di base. La Calabria si trova, rispetto alle altre regioni della serie, in una condizione peculiare: il servizio non è una mera ipotesi né una funzione già consolidata da una legge, ma una misura appena avviata in via amministrativa e sperimentale. Nell'aprile 2026 la Giunta regionale, rimodulando risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, ha istituito lo psicologo di base e ne ha avviato la sperimentazione con circa quaranta professionisti, mentre una proposta di legge per l'istituzione strutturale del servizio è all'esame delle commissioni consiliari. La decisione che le istituzioni sono chiamate ad assumere non riguarda dunque se istituire il servizio, ma se e a quali condizioni consolidarlo in funzione stabile e permanente, in un sistema sanitario che esce, dopo diciassette anni, dal più lungo commissariamento d'Italia e da un piano di rientro i cui obiettivi — l'equilibrio di bilancio e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza — definiscono la cornice entro cui ogni nuova misura deve collocarsi. Lo studio compone in sequenza le undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e le cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi; le appendici ne raccolgono il materiale di riferimento. L'intero studio è fondato su una distinzione cardine, mantenuta in ogni parte: quella tra i risparmi diretti per il bilancio sanitario e le ricadute economico-sociali per la collettività, che non vengono mai sommate in un unico indice di bilancio.

Da tale distinzione discende la tesi centrale dello studio calabrese, articolata in affermazioni congiunte: il servizio costa al bilancio sanitario regionale una cifra modesta — dell'ordine dello 0,6 per cento di un fondo di circa 4,4 miliardi nello scenario di piena attuazione — e comporta un saldo diretto di lieve segno negativo, ossia un onere netto inferiore allo 0,1 per cento del fondo; restituisce alla collettività un valore dell'ordine di tre-cinque euro per ogni euro speso, con un rapporto beneficio-costi compreso fra 3,4 e 4,6 a uno, entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno includendo i benefici di salute; risponde a un bisogno ampio e inevaso, stimato dal Ministero della Salute in circa 470.000 persone, in una regione demograficamente giovane ma erosa dall'esodo dei giovani e segnata da un divario fra il bisogno e la presa in carico fra i più ampi del Paese; riduce le disuguaglianze sociali e territoriali, che in Calabria costituiscono la ragione preminente dell'intervento; e agisce, attraverso la riduzione della mobilità sanitaria passiva — la più elevata d'Italia, pari a 326,9 milioni di euro l'anno — sullo stesso squilibrio che il piano di rientro mira a sanare, configurandosi così non solo come costo compatibile con il risanamento, ma come suo strumento. Rispetto alle altre regioni della serie, la Calabria occupa una posizione che ne fa un caso a sé: è la regione che ha avviato il servizio per via amministrativa con fondi europei in attesa di un consolidamento normativo, che esce dal più lungo commissariamento sanitario d'Italia, che è inadempiente rispetto ai livelli essenziali di assistenza e che registra il valore più elevato d'Italia di mobilità sanitaria passiva. L'analisi multi-criterio che conclude lo studio assegna al consolidamento del servizio un punteggio di 78,30 su 100, contro 35,05 del non intervento.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto; il documento prosegue poi con le parti e le appendici in sequenza.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.4	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito, caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, divari, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	Intervento e modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, due casi
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, sensibilità, scenari, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: gradiente sociale, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, reclutamento, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, controfattuale, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazione, condizioni, conclusione
Appendici A-E	A-E	Caso di riferimento e parametri, strumenti ed esiti, dati regionali, checklist, glossario

Tabella. La mappa di lettura del corpus: undici parti narrative e cinque appendici.

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa parte definisce il perimetro dello studio: ne enuncia lo scopo e il quesito di valutazione, individua la popolazione, l'intervento e il termine di confronto, dichiara il metodo, la prospettiva e le fonti, e descrive la governance dei dati e la struttura dell'opera. La Calabria presenta, rispetto alle altre regioni della serie, una condizione peculiare che ne orienta l'intero impianto: il servizio di psicologia di base non è una mera ipotesi né un servizio già consolidato per legge, ma una misura appena avviata in via amministrativa e sperimentale, che attende di essere stabilizzata e dimensionata, in un sistema sanitario regionale che esce, dopo diciassette anni, dal più lungo commissariamento d'Italia. È in questo spazio — fra una sperimentazione già in corso e una struttura ancora da costruire, fra il vincolo del piano di rientro e l'obbligo di garantire i livelli essenziali — che lo studio si colloca e a cui offre il proprio fondamento conoscitivo.

A.1 Lo scopo e il quesito di valutazione

Lo studio ha per scopo la valutazione, secondo il metodo della valutazione di tecnologia sanitaria, dell'introduzione strutturale del servizio di psicologia di base nel Servizio Sanitario della Regione Calabria. La valutazione di tecnologia sanitaria è un processo multidisciplinare che esamina un intervento sanitario lungo una pluralità di dimensioni — il bisogno, l'efficacia, la sicurezza, i costi e le conseguenze economiche, l'equità, i profili etici, giuridici e organizzativi, le condizioni di attuazione e di monitoraggio — integrando l'evidenza scientifica con l'analisi del contesto in cui l'intervento dovrebbe operare. Essa fornisce ai decisori non una raccomandazione apodittica, ma un quadro ordinato e trasparente di informazioni e di giudizi, sul quale la decisione politica possa fondarsi in modo informato. Nel caso calabrese, la decisione che lo studio è chiamato a sostenere ha una fisionomia particolare, che lo distingue da quella delle regioni in cui il servizio non esiste e da quella delle regioni in cui esso è già istituito da una legge regionale pienamente operativa.

La particolarità discende dalla sequenza degli atti che hanno preceduto questo studio. Nell'aprile 2026 la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Welfare e all'inclusione sociale, ha approvato l'aggiornamento del piano regionale di supporto alle fragilità, rimodulando le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus per il periodo 2021-2027 e istituendo per via amministrativa lo psicologo di base, destinato a operare all'interno delle strutture sanitarie regionali accanto ai medici di medicina generale; è stato contestualmente annunciato l'avvio del servizio in via sperimentale, con circa quaranta psicologi distribuiti sul territorio regionale e con la stipula imminente di convenzioni con le aziende sanitarie provinciali. Parallelamente, una proposta di legge per l'istituzione del servizio di psicologia di base — articolata in disposizioni che ne definiscono i beneficiari e gli obiettivi, ne disciplinano l'organizzazione mediante elenchi provinciali degli psicologi, ne istituiscono un osservatorio regionale e ne prevedono una clausola valutativa e una norma finanziaria — è all'esame delle competenti commissioni del Consiglio regionale. La Calabria si trova dunque in una fase intermedia: ha avviato il servizio in via sperimentale con risorse europee, ma non ne ha ancora definito l'assetto strutturale né la copertura ordinaria, e dispone di uno strumento legislativo non ancora approvato che potrebbe conferirgli stabilità. A questa fisionomia si aggiunge un dato che ne illumina la direzione: la Calabria è stata la prima regione italiana a introdurre lo psicologo scolastico, segnalando un'attenzione istituzionale al disagio psichico, e in particolare a quello giovanile, che precede e accompagna l'introduzione dello psicologo di base.

Il quesito di valutazione che ne deriva può essere enunciato come segue: se, e a quali condizioni di assetto, di dimensionamento e di copertura, convenga consolidare in servizio strutturale e permanente la sperimentazione già avviata, in un sistema sanitario regionale che esce dal commissariamento e dal piano di rientro e che deve perciò conciliare ogni nuova misura con il duplice vincolo dell'equilibrio di bilancio e della garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Il quesito non è dunque se istituire il servizio — la Giunta lo ha già fatto in via amministrativa — ma se trasformare un avvio sperimentale, finanziato con risorse europee a termine, in una funzione stabile del sistema, dotandola di una base normativa, di un dimensionamento adeguato e di una copertura sostenibile; e, in subordine, quale fra le possibili configurazioni del servizio massimizzi il valore prodotto in rapporto alle risorse impiegate e alle condizioni del contesto. Lo studio risponde a questo quesito costruendo, sui dati regionali e sull'evidenza disponibile, la valutazione delle conseguenze cliniche, economiche, distributive e organizzative del consolidamento del servizio, e ponendo tali conseguenze a confronto con quelle del mantenimento dello stato attuale, in cui il servizio resta una sperimentazione limitata e priva di assetto strutturale.

A.2 La popolazione, l'intervento e il confronto

La popolazione di riferimento dello studio è costituita dai residenti in Calabria che presentano un disagio psichico comune — i disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve e moderata e le condizioni di sofferenza sottosoglia — per i quali l'intervento psicologico precoce al primo livello di assistenza è appropriato ed efficace. Si tratta della larga maggioranza del bisogno di salute mentale della popolazione, quella che oggi, in

assenza di un primo livello psicologico strutturato, resta in larga parte priva di risposta o riceve risposte improprie, prevalentemente di natura farmacologica o specialistica, o ancora non riceve risposta alcuna e si traduce in una domanda inevasa che alimenta, a valle, il ricorso al pronto soccorso, il consumo di farmaci e la mobilità verso altre regioni. Le rilevazioni del Ministero della Salute stimano in circa 470.000 i calabresi che convivono con un disturbo mentale o con una condizione sottosoglia, una quota dell'ordine di un quarto della popolazione regionale; di questi, solo una frazione minima — poco più di diciassettemila persone — risulta formalmente in carico ai servizi specialistici, a testimonianza dell'ampiezza del divario fra il bisogno e la presa in carico. Ai fini delle stime economiche, lo studio adotta una definizione prudenziale del disagio comune, riferita a circa il venti per cento della popolazione, pari a un ordine di grandezza di 367.000 persone, mantenendo così le proiezioni su una base conservativa.

L'intervento valutato è il servizio di psicologia di base, inteso come funzione psicologica stabile collocata al primo livello delle cure primarie territoriali. Nel modello che lo studio assume, lo psicologo di base opera all'interno delle Case della Comunità e delle altre strutture territoriali, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, ed è accessibile sia per invio da parte del medico sia, entro le modalità che la regione definirà, per accesso diretto del cittadino. La sua attività comprende l'accoglienza e l'ascolto della domanda, la valutazione del bisogno, l'erogazione di interventi psicologici brevi di efficacia documentata, l'orientamento ai servizi specialistici nei casi che lo richiedano e la collaborazione con il medico nella gestione integrata dei pazienti. Il modello organizzativo si fonda sul principio delle cure gradualità, per cui l'intensità dell'intervento è commisurata alla gravità del bisogno, e incorpora l'uso della telepsicologia come strumento ordinario, particolarmente rilevante in una regione di vasta estensione, di insediamento disperso e di accentuata difficoltà di accesso ai servizi. L'intervento così definito coincide, nelle sue funzioni essenziali, con quello che la sperimentazione avviata dalla Giunta ha cominciato a realizzare; lo studio ne valuta la generalizzazione e la stabilizzazione su scala regionale.

Il termine di confronto è lo stato attuale, ossia la condizione in cui versa la Calabria in assenza di un servizio di psicologia di base strutturale. Questa condizione non coincide con il nulla: esiste una sperimentazione appena avviata, limitata a circa quaranta psicologi e finanziata con risorse europee a termine; esistono i Dipartimenti di Salute Mentale, organizzati su cinque dipartimenti, quarantatré centri territoriali e un numero limitato di strutture residenziali e semiresidenziali; esiste una rete di servizi che tuttavia intercetta solo una minima parte del bisogno. Il confronto rilevante è dunque fra il consolidamento strutturale del servizio, esteso e stabilizzato su scala regionale, e la prosecuzione dello stato attuale, in cui il primo livello psicologico resta sperimentale, frammentario e privo di assetto permanente, e in cui la domanda inevasa continua a tradursi in ricorso improprio agli altri livelli del sistema e in mobilità verso altre regioni. Gli esiti considerati nel confronto sono di tre ordini: gli esiti clinici, espressi dalla riduzione della sintomatologia e dal guadagno di anni di vita ponderati per la qualità; gli esiti di sistema, espressi dalla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, del consumo di farmaci, dei ricoveri, delle prestazioni specialistiche e della mobilità sanitaria passiva; e gli esiti di equità, espressi dalla riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali nell'accesso alla cura della salute mentale. L'orizzonte temporale del confronto è di cinque anni, coerente con la durata entro cui gli effetti clinici ed economici dell'intervento si manifestano in misura apprezzabile.

A.3 Il metodo, la prospettiva e le fonti

Lo studio adotta il metodo della valutazione di tecnologia sanitaria, articolato secondo un telaio a nove domini che corrispondono alle parti dell'opera. Al cuore della valutazione vi è l'analisi economica, condotta secondo tre tecniche complementari: l'analisi di costo-utilità, che esprime il costo dell'intervento per anno di vita ponderato per la qualità guadagnato; l'analisi di impatto sul bilancio, che misura l'effetto netto dell'intervento sulla spesa sanitaria regionale lungo i suoi diversi canali; e l'analisi del ritorno sociale sull'investimento, che esprime in termini monetari il valore sociale complessivo generato per la collettività. A queste si affianca la

modellazione del decorso clinico mediante un modello di Markov, che rappresenta la transizione dei pazienti fra gli stati di salute e ne proietta gli esiti lungo l'orizzonte temporale, e l'analisi dell'incertezza, condotta in forma sia deterministica sia probabilistica, che verifica la robustezza dei risultati rispetto alla variazione dei parametri.

La prospettiva della valutazione merita, nel caso calabrese, una precisazione particolare. Lo studio adotta in via principale la prospettiva del Servizio Sanitario Regionale, che considera i costi e i risparmi che gravano sul bilancio sanitario, e in via complementare la prospettiva della collettività, che considera anche le ricadute economiche e sociali che si producono al di fuori del bilancio sanitario. Le due prospettive sono tenute rigorosamente distinte, e i risparmi diretti per il bilancio non sono mai sommati alle ricadute sociali in un unico indice. La preminenza della prospettiva del bilancio sanitario non è, in Calabria, una scelta meramente metodologica: essa discende dalla condizione del sistema sanitario regionale, che esce da un lungo regime di commissariamento e da un piano di rientro il cui scopo è precisamente il riequilibrio dei conti unito alla garanzia dei livelli essenziali. In tale condizione, ogni nuova misura deve dimostrare la propria compatibilità con il vincolo di bilancio, e il suo effetto sui conti sanitari assume un rilievo decisivo. Lo studio assume perciò come criterio primario la sostenibilità finanziaria della misura per il bilancio regionale, e mostra come l'introduzione del servizio incida sui canali di spesa che il piano di rientro mira a contenere — il ricorso improprio al pronto soccorso, il consumo di farmaci, i ricoveri evitabili e, soprattutto, la mobilità sanitaria passiva, che in Calabria raggiunge il valore più elevato d'Italia.

Le fonti dello studio sono di tre nature. Le fonti del contesto regionale comprendono i dati demografici del censimento permanente dell'Istituto Nazionale di Statistica aggiornati al 2024, i dati sulla mobilità sanitaria della Fondazione Gimbe riferiti al 2023, le rilevazioni del Ministero della Salute sulla salute mentale, i documenti della programmazione sanitaria regionale, fra cui il programma operativo del piano di rientro, e gli atti regionali relativi all'avvio del servizio. Le fonti dell'evidenza scientifica comprendono la letteratura internazionale sull'efficacia degli interventi psicologici brevi nelle cure primarie e sulla loro valutazione economica, da cui sono tratti i parametri clinici del modello. Le fonti normative comprendono la Costituzione, la legislazione nazionale sull'ordinamento sanitario, il decreto ministeriale del 2022 sugli standard dell'assistenza territoriale, che colloca la funzione psicologica nelle Case della Comunità, e la giurisprudenza costituzionale rilevante, in particolare la sentenza che ha definito i limiti entro cui una legge regionale può disciplinare il servizio. I parametri economici regionali, in assenza di rilevazioni dirette consolidate — una carenza che in Calabria è resa più acuta dalla storica difficoltà di approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie — sono stimati in bande prudenziali, con proiezioni conservative e falsificabili, destinate a essere sostituite dalle misure dirette che il sistema informativo e il piano di monitoraggio consentiranno di raccogliere.

A.4 La governance dei dati e la struttura dello studio

La governance dei dati costituisce, in uno studio di questa natura, una condizione di legittimità e di qualità. I dati personali necessari alla valutazione e al monitoraggio del servizio — le variabili anagrafiche e di contesto, le variabili relative all'accesso e al percorso, i punteggi degli strumenti di misurazione degli esiti — devono essere trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con le garanzie di minimizzazione, di finalità e di sicurezza che essa impone. Lo studio assume che la rilevazione di tali dati avvenga in modo strutturato, mediante un sistema informativo che alimenti contestualmente la gestione clinica e la valutazione, e che i dati siano disaggregabili per le variabili rilevanti all'analisi dell'equità — la condizione sociale, la collocazione territoriale fra polo e area interna — così da consentire la verifica degli obiettivi distributivi. La qualità della governance dei dati assume in Calabria un rilievo accresciuto: la regione ha conosciuto una prolungata difficoltà nella tenuta e nell'approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie, sicché la costruzione di un sistema informativo affidabile per il nuovo servizio è insieme una necessità tecnica e un'occasione di rafforzamento complessivo della capacità di rilevazione del sistema.

Lo studio è strutturato in undici parti narrative, dalla A alla M secondo l'alfabeto italiano che salta le lettere J e K, e in cinque appendici, dalla A alla E. La presente Parte A definisce il quadro, il quesito e il metodo. La Parte B analizza il bisogno e il contesto, descrivendo la demografia, l'epidemiologia del disagio, la domanda e l'offerta, le disuguaglianze, i flussi di mobilità e il quadro normativo. La Parte C definisce l'intervento e il modello organizzativo, comprensivi del percorso clinico, del sistema informativo, dell'intelligenza artificiale e della formazione. La Parte D esamina l'efficacia e la qualità dell'evidenza. La Parte E sviluppa la valutazione economica nelle sue diverse componenti. La Parte F sviluppa la modellazione e l'analisi dell'incertezza. La Parte G analizza l'equità e l'impatto distributivo. La Parte H esamina i profili etici, giuridici e organizzativi. La Parte I tratta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità. La Parte L definisce il monitoraggio e la valutazione successiva all'introduzione. La Parte M offre la sintesi multidimensionale e la raccomandazione. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri del modello, gli strumenti di misurazione e il dataset minimo, i dati regionali e quelli da acquisire, la lista di controllo per la rendicontazione e il glossario. La struttura segue l'ordine logico della valutazione, dal problema di salute alla raccomandazione conclusiva, e consente al lettore di percorrere l'intero ragionamento o di accedere direttamente alla parte di suo interesse.^[2185]

Parte B — Bisogno e contesto

Questa parte ricostruisce il bisogno di salute a cui il servizio di psicologia di base intende rispondere e il contesto in cui esso opererebbe. Ne esamina in successione la demografia, l'epidemiologia del disagio psichico, il rapporto fra la domanda e l'offerta, le disuguaglianze sociali e territoriali, i flussi della mobilità sanitaria e il quadro normativo. Il bisogno e il contesto calabresi presentano una combinazione che non si ritrova in nessun'altra regione della serie: una popolazione demograficamente giovane ma erosa da un esodo che ne sottrae proprio le generazioni più giovani, un sistema sanitario che esce dal più lungo commissariamento d'Italia, il valore più elevato del Paese di mobilità sanitaria passiva, l'inadempienza nei livelli essenziali di assistenza e una spesa per la salute mentale fra le più basse in assoluto. È in questa combinazione che si misura la rilevazione del bisogno e si fonda la valutazione dell'intervento.

B.1 La demografia

La Calabria conta, secondo il censimento permanente dell'Istituto Nazionale di Statistica aggiornato al 31 dicembre 2024, 1.834.646 residenti, in calo di 3.922 unità rispetto all'anno precedente, pari a una diminuzione dello 0,2 per cento. La popolazione è distribuita su 404 comuni e cinque province, con una forte concentrazione nelle due province maggiori: oltre il sessanta per cento dei residenti vive nelle province di Cosenza, che da sola ne raccoglie circa il 36 per cento, e di Reggio Calabria, che ne raccoglie circa il 28 per cento; segue Catanzaro con circa il 18 per cento, mentre Crotone e Vibo Valentia ospitano insieme la quota restante, dell'ordine del 17 per cento. La distribuzione insediativa è marcatamente dispersa: più di un quarto della popolazione, il 28,3 per cento, vive in comuni di ampiezza compresa fra mille e cinquemila abitanti, e oltre un quinto, il 20,9 per cento, in comuni fra cinquemila e diecimila. La componente straniera ammonta a 105.439 persone, pari al 5,7 per cento della popolazione, con un'incidenza inferiore alla media nazionale e provenienze prevalenti da Romania, Marocco e Ucraina.

La struttura per età della popolazione calabrese presenta un tratto che, se considerato isolatamente, distingue la regione dalla maggior parte di quelle meridionali e ne fa una delle più giovani d'Italia: l'età media, pari nel 2024 a 46,2 anni, è inferiore alla media nazionale di 46,9 anni, e l'indice di vecchiaia, sebbene in crescita e attestato intorno a 196,7 anziani ogni cento giovani, resta inferiore a quello di regioni più anziane. La provincia di Crotone, con un'età media di 44,8 anni, è fra le più giovani d'Italia, mentre Catanzaro e Cosenza, entrambe a 46,7 anni, sono le più anziane della regione; il comune di Platì, in provincia di Reggio Calabria, è il più giovane del Paese. Questa relativa giovinezza demografica, tuttavia, non descrive adeguatamente la dinamica reale della

popolazione, e rischia anzi di occultarla. La Calabria è infatti una delle regioni con il più sfavorevole tasso di migrazione interna, dell'ordine di meno 5,4 per mille, fra i peggiori d'Italia: i suoi giovani e i suoi residenti in età lavorativa emigrano verso le regioni del Centro e del Nord in misura tale che la giovinezza della struttura per età si va progressivamente erodendo. A ciò si aggiunge una denatalità che nel 2024 ha toccato il minimo storico, con 12.679 nati, 603 in meno rispetto all'anno precedente, a fronte di una mortalità in calo che mantiene comunque negativo il saldo naturale. Il quadro che ne risulta è quello di una popolazione che perde i propri giovani per emigrazione e non li rinnova per nascita, con il duplice effetto di uno spopolamento progressivo, particolarmente acuto nelle aree interne montane, e di un disagio diffuso connesso alla separazione delle famiglie, alla precarietà delle prospettive e all'abbandono dei territori. La vasta estensione della regione, l'asprezza del territorio montano — la Sila, l'Aspromonte, il Pollino — e la dispersione degli insediamenti rendono inoltre l'accesso fisico ai servizi sanitari strutturalmente difficile per una parte rilevante della popolazione, e fanno della telepsicologia non un complemento accessorio, ma una condizione di effettiva accessibilità del servizio.

B.2 L'epidemiologia del disagio psichico

La dimensione del disagio psichico in Calabria è documentata da una pluralità di fonti convergenti. Secondo le rilevazioni del Ministero della Salute riferite al 2024, circa 470.000 calabresi convivono con un disturbo mentale o con una condizione di sofferenza sottosoglia, una quota dell'ordine di un quarto della popolazione regionale, compresa secondo le stime fra il venti e il venticinque per cento. La larga maggioranza di questo disagio è costituita dai disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve e moderata e dalle condizioni sottosoglia, ossia precisamente da quella sofferenza comune per la quale l'intervento psicologico precoce al primo livello di assistenza è appropriato ed efficace, e che lo studio assume, in via prudenziale e su una base conservativa pari a circa il venti per cento della popolazione, come bisogno di riferimento dell'ordine di 367.000 persone. La distribuzione del disagio non è uniforme nella popolazione, ma segue il gradiente della deprivazione sociale: la documentazione della programmazione sanitaria regionale riconosce esplicitamente come la maggiore domanda di servizi sanitari in Calabria sia riconducibile a fattori quali la scarsa istruzione, la carenza di lavoro e le condizioni abitative e familiari disagiate, parametri che concorrono all'indice di deprivazione e che la regione presenta in misura fra le più elevate del Paese.

Particolare rilievo assume, nel contesto calabrese, il disagio delle fasce giovanili e di quelle anziane. Il disagio giovanile, che ha trovato espressione anche in recenti e drammatici fatti di cronaca, è stato all'origine dell'impegno regionale che ha condotto la Calabria a essere la prima regione italiana a introdurre lo psicologo scolastico; esso costituisce una componente rilevante del bisogno complessivo e si lega, nel territorio calabrese, alle prospettive di emigrazione e di precarietà che gravano sulle nuove generazioni. Il disagio degli anziani, accentuato dall'isolamento connesso allo spopolamento delle aree interne, presenta una prevalenza di sintomi depressivi che, nelle fasce socialmente ed economicamente più fragili, può raggiungere quote molto elevate. A questi si aggiunge la considerazione, di portata generale ma di particolare gravità in un contesto di offerta carente, che la depressione non adeguatamente trattata si associa a una riduzione dell'aspettativa di vita stimabile in circa dieci anni, sicché il mancato intervento sul disagio comune non è privo di conseguenze sulla salute fisica e sulla sopravvivenza. Il disagio psichico comune, in sintesi, non è in Calabria un problema marginale o circoscritto, ma un fenomeno di massa, diffuso nell'intera popolazione e accentuato nelle fasce e nei territori più fragili, la cui ampiezza eccede largamente la capacità di risposta dei servizi esistenti.

B.3 La domanda, l'offerta e il divario

Il confronto fra la dimensione del bisogno e la capacità di risposta del sistema rivela un divario di proporzioni considerevoli. A fronte di circa 470.000 persone con un disturbo o una condizione sottosoglia, risultano formalmente in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale, nel corso del 2023, soltanto 17.636 persone: una

frazione minima del bisogno, che lascia la stragrande maggioranza della domanda priva di una presa in carico specialistica. Questa domanda inevasa non scompare, ma si manifesta per altre vie e ricade su altri livelli del sistema. La manifestazione più visibile è il ricorso al pronto soccorso: i pronto soccorso calabresi registrano in un anno 15.407 accessi per problemi psichiatrici, oltre quaranta al giorno, in larga parte per sintomi di ansia, depressione e sindromi nevrotiche che un primo livello psicologico avrebbe potuto intercettare e trattare in modo più appropriato e meno costoso. I servizi territoriali erogano circa 164.000 prestazioni l'anno, di cui poco più di ottomila a domicilio, una quantità che, per quanto significativa, non riesce a stare al passo con l'ampiezza del disagio.

L'offerta dei servizi di salute mentale si articola in una rete che, pur dotata di una base infrastrutturale, è quantitativamente inadeguata rispetto al bisogno: cinque Dipartimenti di Salute Mentale, quarantatré centri territoriali, ventidue strutture residenziali e cinque semiresidenziali, con poco più di quattrocento posti letto residenziali e una cinquantina di semiresidenziali, e una spesa psichiatrica territoriale dell'ordine di ottantotto milioni di euro. A questa rete si aggiunge, dall'aprile 2026, la sperimentazione dello psicologo di base avviata dalla Giunta regionale, limitata a circa quaranta professionisti distribuiti sull'intero territorio regionale: una misura che segna una direzione, ma che per dimensione è ancora largamente insufficiente a colmare il divario. Il primo livello psicologico — la funzione di accoglienza, ascolto, valutazione e intervento breve collocata nelle cure primarie, accanto al medico di medicina generale — è, allo stato, quasi interamente assente, e la sua assenza è la ragione strutturale per cui il disagio comune resta privo di risposta o riceve risposte improprie. Il decreto ministeriale del 2022 sugli standard dell'assistenza territoriale colloca espressamente la funzione psicologica al primo livello, nelle Case della Comunità, ma in Calabria tali strutture sono in larga parte ancora in corso di realizzazione nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sicché la cornice organizzativa entro cui il servizio dovrebbe operare è essa stessa in costruzione. Il divario fra il bisogno e la presa in carico — fra centinaia di migliaia di persone in sofferenza e poche decine di migliaia in cura, fra la domanda diffusa e i quaranta psicologi della sperimentazione — definisce con precisione lo spazio che il consolidamento strutturale del servizio è chiamato a colmare.

B.4 Le disuguaglianze sociali e territoriali

Il disagio psichico in Calabria si dispone lungo due assi di disuguaglianza che si intersecano e si rafforzano. Il primo asse è quello sociale: la prevalenza del disagio è più elevata nelle fasce socialmente ed economicamente più deboli, mentre la capacità di accedere a una cura adeguata, e in particolare a una cura psicologica privata in assenza di un'offerta pubblica, è in queste stesse fasce più ridotta; ne deriva che il bisogno è massimo dove la possibilità di risposta autonoma è minima, e che l'assenza di un servizio pubblico gratuito o a basso costo colpisce in misura maggiore proprio chi ne avrebbe più bisogno. In una regione che presenta fra i più elevati indici di deprivazione del Paese — per livelli di istruzione, condizione occupazionale e condizioni abitative — questo asse di disuguaglianza assume un peso particolarmente rilevante. Il secondo asse è quello territoriale, e si articola a sua volta su due livelli. A livello nazionale, la Calabria è nel suo complesso una regione svantaggiata: il sistema sanitario regionale è inadempiente rispetto alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con un punteggio di valutazione attestatosi intorno a 125, ben al di sotto della soglia di adempienza fissata a 160 e in peggioramento rispetto al 162 registrato nel 2018; la regione, cioè, non garantisce ai propri cittadini i livelli di assistenza che la Costituzione impone in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. A livello interno, all'interno della regione, le aree montane e interne — disperse, spopolate e distanti dai poli urbani di Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro — soffrono di una difficoltà di accesso ai servizi assai maggiore di quella delle aree costiere e urbane.

A questi due assi si sovrappone una terza, decisiva, disuguaglianza, interna al sistema sanitario stesso: il sottofinanziamento della salute mentale. La Calabria destina alla salute mentale una quota del proprio fondo sanitario regionale inferiore al 2,5 per cento, collocandosi fra le regioni fanalino di coda d'Italia, ben al di sotto della soglia del cinque per cento a cui le regioni si erano impegnate e della media europea. Si configura così una

condizione di doppio svantaggio: il dominio della salute mentale, già il più trascurato del sistema sanitario, è particolarmente trascurato in una delle regioni più svantaggiate del Paese, sicché il cittadino calabrese che soffre di disagio psichico cumula lo svantaggio di vivere in una regione con offerta sanitaria carente e quello di soffrire in un ambito a cui è destinata una quota di risorse fra le più basse. A complicare il quadro concorrono lo stigma, che induce una parte rilevante delle persone a sospendere i trattamenti o a non presentarsi agli interventi, e il sottoutilizzo della telemedicina, che in metà dei centri non è impiegata per carenza di indirizzi regionali, aggravando il divario digitale che si somma a quello territoriale. La riduzione di queste disuguaglianze costituisce, in Calabria più che altrove, non un effetto collaterale dell'intervento, ma una delle sue ragioni preminenti, e si lega direttamente al rispetto del principio costituzionale per cui la tutela del diritto alla salute è preminente rispetto all'equilibrio di bilancio.

B.5 I flussi e la mobilità sanitaria

Il dato che, più di ogni altro, caratterizza il contesto sanitario calabrese e ne illumina la rilevanza economica è quello della mobilità sanitaria passiva. Secondo il report della Fondazione Gimbe riferito al 2023, la Calabria registra un saldo negativo di mobilità sanitaria pari a 326,9 milioni di euro, in aumento di 22,1 milioni rispetto all'anno precedente: si tratta del passivo più elevato d'Italia in valore assoluto. Il saldo è composto da crediti per circa 35,4 milioni, che collocano la regione in diciottesima posizione nazionale per capacità di attrazione, e da debiti per circa 362,4 milioni, che la collocano in quinta posizione per spesa sostenuta a favore di altre regioni; in termini pro capite, l'impatto del saldo negativo è stimato in circa 178 euro per residente, fra i più gravosi del Paese. La Calabria, insieme a Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia, concentra oltre il settantotto per cento del saldo passivo complessivo nazionale, in un flusso strutturalmente orientato dal Mezzogiorno verso le regioni del Centro e del Nord. Una quota rilevante di questa spesa, inoltre, non confluisce verso strutture pubbliche ma verso il privato accreditato, che a livello nazionale incassa oltre la metà della spesa per prestazioni specialistiche rese fuori regione.

La mobilità sanitaria passiva non è, come ha osservato il presidente della Fondazione Gimbe, un fenomeno neutro: essa è fra gli indicatori più sensibili delle disuguaglianze del sistema sanitario regionale, e segnala dove i cittadini trovano risposte adeguate e dove invece sono costretti a spostarsi per curarsi; sempre meno una scelta e sempre più una necessità. Per la Calabria, questo significa che ogni anno centinaia di milioni di euro e migliaia di pazienti lasciano la regione per ricevere altrove cure che la regione non riesce a garantire, con un duplice danno: la sottrazione di risorse al sistema sanitario regionale, già gravato dal piano di rientro, e l'aggravio per i cittadini, costretti a sostenere i costi e i disagi dello spostamento. Il legame fra la mobilità passiva e il disagio psichico non trattato è, in parte, indiretto ma reale: una quota della mobilità è riconducibile, a monte, a condizioni di disagio psichico non intercettato che si traducono in somatizzazioni, in comorbidità che aggravano patologie fisiche, in percorsi di cura abbandonati o cercati altrove. Un primo livello psicologico efficace, intercettando precocemente il disagio comune e gestendolo in prossimità, può contribuire a ridurre la quota impropria di questa mobilità, agendo così sul più ampio bacino di risparmio diretto disponibile in Italia. A questa mobilità sanitaria si affianca, e con essa si intreccia, la migrazione interna della popolazione: l'emigrazione dei giovani e dei residenti in età lavorativa verso il Centro e il Nord, che impoverisce demograficamente la regione e accresce il disagio connesso alla separazione e allo spopolamento, costituendo a sua volta un fattore di domanda di salute mentale.

B.6 Il quadro normativo

Il quadro normativo entro cui si colloca l'introduzione del servizio si compone di un livello nazionale, di un livello regionale e di vincoli giurisprudenziali specifici. A livello nazionale, l'ordinamento del Servizio Sanitario, definito dalla legge istitutiva del 1978 e dal decreto legislativo di riordino del 1992, attribuisce alle regioni l'organizzazione dell'assistenza sanitaria nel rispetto dei livelli essenziali; il decreto ministeriale del

2022 sugli standard dell'assistenza territoriale colloca espressamente la funzione psicologica al primo livello, nelle Case della Comunità, in collaborazione con i medici di medicina generale, fornendo così la cornice nazionale entro cui il servizio di psicologia di base trova collocazione. Un vincolo specifico discende dalla giurisprudenza costituzionale: la sentenza numero 241 del 2021, che ha definito i limiti entro cui una legge regionale può disciplinare il servizio, escludendo che la regione possa istituire autonomamente rapporti convenzionali di tipo libero-professionale eccedenti la propria competenza. Questo vincolo è di particolare rilievo per la Calabria, sotto due profili: da un lato, la proposta di legge in esame deve essere costruita in modo da rispettarlo, configurando un servizio legittimo nel suo assetto; dall'altro, la via amministrativa scelta dalla Giunta — l'avvio della sperimentazione mediante la rimodulazione di fondi europei del Fondo Sociale Europeo Plus, anziché mediante l'istituzione di rapporti convenzionali — si colloca su un piano distinto, che ha consentito di avviare il servizio senza incorrere immediatamente nei limiti censurati. Va inoltre richiamato il principio, affermato dalla Corte costituzionale, per cui la tutela dei diritti fondamentali, fra cui il diritto alla salute, è preminente rispetto al pareggio di bilancio: principio che assume rilievo decisivo in una regione in cui la garanzia dei livelli essenziali nella salute mentale rischia di essere sacrificata alle esigenze del rientro.

A livello regionale, il quadro è definito dalla sequenza di atti già richiamata. La deliberazione della Giunta regionale dell'aprile 2026, aggiornando il piano regionale di supporto alle fragilità e rimodulando le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, ha istituito per via amministrativa lo psicologo di base e ne ha avviato la sperimentazione. La proposta di legge per l'istituzione del servizio di psicologia di base, all'esame delle commissioni consiliari, ne disciplinerebbe l'assetto strutturale: essa istituisce il servizio, ne individua i beneficiari e gli obiettivi, prevede la creazione di elenchi provinciali degli psicologi di base, ne detta l'organizzazione, istituisce un osservatorio regionale con funzioni di controllo e indirizzo, e contiene una clausola valutativa e una norma finanziaria; la relazione che l'accompagna richiama espressamente, fra i precedenti, le leggi regionali della Campania e della Puglia del 2020 e la giurisprudenza costituzionale rilevante. Su tutto sovrasta la cornice del piano di rientro e del programma operativo, il cui obiettivo dichiarato è la completa erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto dell'equilibrio economico, e la condizione, in evoluzione, dell'uscita dal commissariamento, decisa dal Consiglio dei Ministri nell'aprile 2026 e in attesa di efficacia. Il consolidamento strutturale del servizio dovrà dunque inserirsi in questa cornice, conciliando l'ampliamento dell'offerta con il vincolo di bilancio e fondando la propria legittimità sia sulla base normativa che la proposta di legge intende fornire, sia sulla compatibilità con gli obiettivi del rientro, di cui il servizio può anzi divenire uno strumento, contribuendo alla riduzione della spesa impropria e della mobilità passiva. ^[2186]

Parte C — Intervento e modello

Questa parte definisce l'intervento oggetto della valutazione e ne descrive il modello organizzativo. Ne precisa anzitutto la natura e i confini, distinguendolo dalle figure e dai servizi affini; ne illustra poi l'assetto organizzativo, il percorso clinico, il sistema informativo, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e la formazione del personale. Il modello che lo studio assume non è una costruzione astratta: esso parte dalla sperimentazione che la Regione Calabria ha già avviato e ne descrive la generalizzazione e la stabilizzazione in servizio strutturale, calandola nelle condizioni organizzative reali del sistema sanitario regionale — la rete delle Case della Comunità in costruzione, l'articolazione in cinque aziende sanitarie provinciali, la centralizzazione del reclutamento, il vincolo del piano di rientro.

C.1 La definizione del servizio

Il servizio di psicologia di base è una funzione psicologica stabile collocata al primo livello delle cure primarie territoriali, destinata a intercettare e a trattare il disagio psichico comune nella popolazione generale. La sua attività si compone di un insieme definito di prestazioni: l'accoglienza e l'ascolto della domanda che il cittadino o il medico portano; la valutazione del bisogno mediante colloqui e strumenti standardizzati; l'erogazione di interventi psicologici brevi di efficacia documentata, rivolti ai disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve e moderata e alle condizioni di sofferenza sottosoglia; l'orientamento e l'invio ai servizi specialistici nei casi che eccedono il primo livello; e la collaborazione con il medico di medicina generale e con il pediatra di libera scelta nella gestione integrata dei pazienti, compresa l'attenzione alla salute fisica delle persone con disturbi psichici. Si tratta, nelle sue funzioni essenziali, della medesima attività che la sperimentazione avviata dalla Giunta regionale nell'aprile 2026 ha cominciato a realizzare con circa quaranta psicologi; lo studio ne valuta la generalizzazione su scala regionale e la trasformazione in funzione permanente del sistema.

La definizione del servizio richiede che ne siano precisati con chiarezza i confini, tanto più in una regione in cui coesistono già altre figure psicologiche nel sistema pubblico. Il servizio di psicologia di base non coincide con il servizio specialistico dei Dipartimenti di Salute Mentale: questi operano al secondo livello, prendono in carico i disturbi psichiatrici gravi e persistenti e dispongono di strutture residenziali e semiresidenziali, mentre lo psicologo di base opera al primo livello, sul disagio comune, in funzione di intercettazione precoce e di filtro appropriato verso il livello specialistico. Non coincide, inoltre, con lo psicologo scolastico, figura che la Calabria è stata la prima regione italiana a introdurre e che opera negli istituti scolastici a favore di studenti, docenti e famiglie; il servizio di psicologia di base si rivolge alla popolazione generale nelle strutture sanitarie territoriali, sebbene fra le due funzioni esistano evidenti complementarità nella presa in carico del disagio giovanile. Non coincide, infine, con la psicoterapia specialistica di lungo periodo: l'intervento dello psicologo di base è breve, focalizzato e graduato sulla gravità del bisogno, secondo il principio delle cure graduali. Definito in questi termini, il servizio occupa uno spazio oggi quasi interamente vuoto nel sistema sanitario calabrese: quello del primo livello psicologico, collocato fra il medico di medicina generale, che intercetta la domanda ma non dispone degli strumenti per trattarla, e il servizio specialistico, che tratta i casi gravi ma non può farsi carico del disagio comune di massa. È il riempimento di questo spazio vuoto che il decreto ministeriale del 2022 sugli standard dell'assistenza territoriale prefigura, collocando la funzione psicologica nelle Case della Comunità, e che la proposta di legge regionale intende disciplinare in modo strutturale.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo del servizio ne definisce la collocazione, la distribuzione, il dimensionamento, il reclutamento e la copertura. Quanto alla collocazione, il servizio si colloca all'interno delle Case della Comunità e delle altre strutture territoriali del sistema sanitario regionale, in collegamento funzionale con le forme organizzative della medicina generale — le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie — e con il ruolo unico della medicina generale. In Calabria, questa collocazione presenta una specificità: le Case della Comunità sono in larga parte ancora in corso di realizzazione nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sicché il servizio dovrà essere organizzato in modo da operare, nella fase transitoria, nelle strutture territoriali disponibili, e da integrarsi progressivamente nelle Case della Comunità man mano che queste entrano in funzione. Quanto alla distribuzione, il servizio si articola sulle cinque aziende sanitarie provinciali — Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia — secondo una ripartizione che deve tenere conto della popolazione, della sua distribuzione fra poli urbani e aree interne, e degli indici di deprivazione e di bisogno, così da non riprodurre nell'allocatione del servizio le disuguaglianze territoriali che esso intende ridurre.

Quanto al dimensionamento, il modello assume un rapporto fra lo psicologo di base e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta coerente con quello indicato dalla proposta di legge e dalla riflessione nazionale, dell'ordine di uno psicologo ogni quattro-sette medici, con una presenza minima per ciascuna Casa della Comunità; tale rapporto si traduce, sulla popolazione calabrese, in una pluralità di scenari di dimensionamento che la Parte E quantifica e la Parte I articola in fasi. Quanto al reclutamento, il modello può avvalersi della centralizzazione che caratterizza il sistema calabrese: l'Azienda Zero, costituita anche con funzioni di reclutamento centralizzato delle risorse umane del sistema sanitario regionale, può procedere all'individuazione e all'assunzione degli psicologi secondo metodologie uniformi, riducendo la frammentazione e i tempi. Quanto alla copertura, infine, il modello deve affrontare la questione che costituisce, in Calabria, il nodo decisivo: la sperimentazione è stata avviata con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, ossia con fondi europei a destinazione e a durata definite, mentre il consolidamento strutturale richiede una copertura ordinaria e permanente, da reperire in un bilancio sanitario soggetto ai vincoli del piano di rientro. La via amministrativa dei fondi europei ha consentito di avviare il servizio senza gravare immediatamente sul bilancio ordinario; la stabilizzazione richiede di individuare una copertura sostenibile, e su questo punto lo studio mostra, nella Parte E e nella Parte I, come l'onere netto del servizio sia modesto in rapporto alle dimensioni del fondo e come esso possa essere in larga parte compensato dai risparmi che il servizio stesso genera, in particolare sulla mobilità sanitaria passiva. Il governo complessivo del servizio è infine affidato, nel disegno della proposta di legge, a un osservatorio regionale con funzioni di controllo e di indirizzo, che raccoglie le relazioni annuali e alimenta la valutazione periodica.

C.3 Il percorso clinico

Il percorso clinico descrive le tappe attraverso cui il cittadino accede al servizio, viene valutato, trattato e, se necessario, indirizzato ad altri livelli. L'accesso avviene per due vie: l'invio da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, che individua nel proprio assistito un bisogno psicologico e lo orienta verso lo psicologo di base; e l'accesso diretto del cittadino, entro le modalità che la regione definirà. La duplice modalità di accesso è importante: l'invio medico valorizza il ruolo del medico di medicina generale come primo intercettatore del disagio e ne rafforza la collaborazione con lo psicologo; l'accesso diretto riduce le barriere e intercetta la quota di disagio che non passa attraverso il medico, particolarmente rilevante fra i giovani e nelle situazioni in cui lo stigma scoraggia la richiesta di aiuto. All'accesso segue la valutazione iniziale, condotta mediante colloqui e strumenti standardizzati di misurazione della sintomatologia e del funzionamento, che consente di definire la natura e la gravità del bisogno e di orientare l'intervento.

Sulla base della valutazione, il percorso si articola secondo il principio delle cure graduali. Per il disagio comune di intensità lieve e moderata, lo psicologo di base eroga un ciclo di interventi psicologici brevi di efficacia documentata, di durata e di numero commisurati al bisogno, al termine del quale il percorso si conclude con il recupero o con la stabilizzazione. Per i casi che eccedono il primo livello — i disturbi di maggiore gravità, le condizioni che richiedono un trattamento specialistico o farmacologico, le situazioni di rischio — lo psicologo di base opera l'invio al Dipartimento di Salute Mentale, garantendo la continuità del percorso e collaborando con il servizio specialistico; la cura della transizione fra i livelli, e in particolare fra i servizi per l'età evolutiva e quelli per gli adulti, costituisce un punto di attenzione, data la lacuna che la riflessione nazionale segnala in questo passaggio. Lungo l'intero percorso, lo psicologo di base collabora con il medico di medicina generale nella gestione integrata del paziente, con attenzione particolare alla salute fisica delle persone con disturbi psichici, la cui aspettativa di vita è ridotta. Un elemento qualifica in modo specifico il percorso clinico nel contesto calabrese: l'uso della telepsicologia. La vasta estensione della regione, l'asprezza del territorio montano e la dispersione degli insediamenti rendono l'accesso fisico ai servizi difficile per una parte rilevante della popolazione, in particolare nelle aree interne; la telepsicologia, intesa come erogazione di

prestazioni a distanza mediante strumenti digitali, non è dunque un complemento accessorio ma una condizione di effettiva accessibilità del servizio, e il percorso clinico la incorpora come modalità ordinaria, accanto alla prestazione in presenza, là dove essa è appropriata e accettata dal paziente.

C.4 Il sistema informativo

Il sistema informativo è l'infrastruttura che consente al servizio di funzionare, di essere governato e di essere valutato. Esso si fonda su un dataset minimo, definito nell'Appendice B, che comprende le variabili anagrafiche e di contesto, le variabili relative all'accesso e al percorso e i punteggi degli strumenti di misurazione degli esiti, rilevati per ogni accesso e per ogni percorso. La rilevazione di questi dati non risponde a una finalità meramente amministrativa: essa alimenta contestualmente la gestione clinica, consentendo la continuità della presa in carico; il governo del servizio, fornendo all'osservatorio regionale gli elementi per il controllo e l'indirizzo; e la valutazione, costituendo la base empirica su cui le stime dello studio potranno, nel tempo, essere sostituite da misure dirette. Il sistema informativo del servizio deve integrarsi con le infrastrutture digitali del sistema sanitario regionale — il fascicolo sanitario elettronico, il centro unico di prenotazione regionale già avviato, le piattaforme gestite a livello centrale — così da evitare duplicazioni e da garantire l'interoperabilità dei dati.

La costruzione di un sistema informativo affidabile assume, in Calabria, un rilievo che eccede la dimensione tecnica e tocca un punto strutturale del sistema sanitario regionale. La regione ha conosciuto, per un lungo periodo, una grave difficoltà nella tenuta e nell'approvazione dei bilanci delle proprie aziende sanitarie, al punto che la programmazione ha dovuto fare i conti con una contabilità in parte non consolidata e con un debito a lungo non interamente quantificato; questa difficoltà è uno dei nodi che il piano di rientro e l'uscita dal commissariamento hanno dovuto affrontare. In un sistema che sconta una simile fragilità nella rilevazione e nel consolidamento dei dati, la costruzione di un sistema informativo rigoroso per il nuovo servizio è insieme una necessità e un'occasione: una necessità, perché senza dati affidabili il servizio non potrebbe essere governato né valutato, e perché le stesse stime economiche dello studio, in assenza di rilevazioni regionali consolidate, debbono ricorrere a parametri prudenziali destinati a essere verificati; un'occasione, perché l'introduzione di un sistema informativo strutturato per la psicologia di base può costituire un tassello del più ampio rafforzamento della capacità di rilevazione del sistema sanitario regionale, in coerenza con la svolta digitale che alcune aziende — fra cui l'azienda sanitaria di Cosenza, nei propri programmi per la salute mentale, i consultori e i servizi per le dipendenze — hanno già intrapreso. La disaggregazione dei dati per le variabili rilevanti all'analisi dell'equità — la condizione sociale, la collocazione territoriale fra polo e area interna — è infine condizione necessaria per la verifica degli obiettivi distributivi, che in Calabria costituiscono una delle ragioni preminenti dell'intervento.

C.5 L'intelligenza artificiale

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel modello del servizio è trattata in questo studio con un criterio di prudenza metodologica: le potenzialità dell'intelligenza artificiale a supporto della psicologia di base sono reali e in rapida evoluzione, ma le affermazioni sulla loro efficacia e sul loro impatto economico sono soggette alla medesima graduazione dell'evidenza che lo studio applica alle affermazioni cliniche, e non sono assunte in misura superiore a quanto l'evidenza disponibile consenta. Entro questo criterio, l'intelligenza artificiale può sostenere il servizio lungo diverse direttrici. Sul versante dell'intercettazione precoce, strumenti digitali di screening e di valutazione iniziale possono coadiuvare l'identificazione del disagio nella popolazione e la sua stratificazione per gravità, ampliando la capacità di intercettazione del primo livello. Sul versante del monitoraggio, piattaforme digitali possono sostenere la rilevazione continua degli esiti e il follow-up dei pazienti, in particolare nei percorsi a distanza, dove la telepsicologia e il monitoraggio digitale si integrano. Sul versante del supporto alla decisione clinica, sistemi di assistenza possono fornire allo psicologo elementi

informativi e indicazioni, in funzione di supporto e non di sostituzione del giudizio professionale, che resta in capo al clinico. Sul versante dell'efficienza organizzativa, infine, l'automazione di funzioni amministrative e documentali può liberare tempo professionale da destinare alla relazione clinica.

Il contesto calabrese presenta, sotto questo profilo, elementi di particolare interesse, che collocano l'integrazione dell'intelligenza artificiale non in un orizzonte ipotetico ma in un percorso già avviato dal sistema sanitario regionale. La Regione ha promosso un accordo fra l'Azienda Zero e l'Università della Calabria per l'introduzione dell'intelligenza artificiale in sanità, segnalando un orientamento istituzionale all'innovazione digitale del sistema; alcune strutture, come l'azienda ospedaliera di Cosenza, hanno avviato l'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale e di realtà aumentata; e alcune aziende sanitarie hanno inserito nei propri programmi una svolta digitale che investe anche i servizi per la salute mentale. Questo orientamento offre al servizio di psicologia di base un terreno favorevole per l'integrazione degli strumenti digitali, particolarmente rilevante in una regione in cui la telepsicologia è condizione di accessibilità e in cui il sottoutilizzo della telemedicina — non impiegata, per carenza di indirizzi regionali, in una parte rilevante dei centri — costituisce oggi un limite da superare. L'integrazione dell'intelligenza artificiale deve infine collocarsi entro la cornice regolatoria europea, che qualifica come ad alto rischio i sistemi di intelligenza artificiale impiegati in ambito sanitario e ne disciplina gli obblighi, con un'articolazione temporale che colloca gli obblighi più stringenti relativi ai dispositivi medici a una scadenza differita e conserva l'obbligo di alfabetizzazione del personale a una scadenza più prossima. Lo studio assume che l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel servizio proceda nel rispetto di tale cornice, con la gradualità e le garanzie che essa impone, e che il suo contributo alla riduzione dei costi sia stimato con la stessa prudenza con cui sono stimati gli altri effetti; l'approfondimento sistematico delle potenzialità dell'intelligenza artificiale e del loro impatto economico costituisce, peraltro, oggetto di una trattazione dedicata, che lo studio sulla psicologia di base richiama ma non esaurisce.

C.6 La formazione

La formazione del personale è condizione di qualità del servizio e presupposto della sua efficacia. Essa investe, in primo luogo, gli psicologi di base, che devono essere preparati a operare in un contesto — le cure primarie territoriali — diverso da quello specialistico e clinico tradizionale: la formazione comprende perciò l'acquisizione delle competenze proprie del primo livello, l'addestramento agli interventi psicologici brevi e graduati, la conoscenza del modello delle cure gradualità, la capacità di collaborare con il medico di medicina generale e con gli altri operatori delle cure primarie, e la padronanza degli strumenti della telepsicologia, particolarmente rilevanti nel contesto calabrese. Essa investe, in secondo luogo, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che devono essere posti in grado di riconoscere il disagio psichico, di orientare l'invio allo psicologo di base e di collaborare con esso nella gestione integrata dei pazienti. La formazione comprende inoltre l'aggiornamento continuo degli operatori, in coerenza con quanto la riflessione nazionale sulla salute mentale raccomanda circa la formazione continua del personale sanitario quale fattore di qualità dell'assistenza.

La Calabria dispone, per la formazione, di risorse che possono essere valorizzate: l'Università della Calabria, già impegnata nell'accordo sull'intelligenza artificiale in sanità, e l'Ordine degli psicologi della Calabria, già attivo nell'organizzazione di percorsi formativi. A queste competenze il servizio può attingere per costruire un'offerta formativa adeguata. Un'attenzione particolare merita, in prospettiva, la formazione all'uso dell'intelligenza artificiale: l'integrazione degli strumenti digitali nel servizio richiede che gli psicologi di base e i medici di medicina generale acquisiscano le competenze necessarie a impiegarli in modo appropriato e consapevole, in coerenza con l'obbligo di alfabetizzazione del personale previsto dalla cornice regolatoria europea. La formazione all'uso dell'intelligenza artificiale può articolarsi su una pluralità di modalità — la formazione universitaria, la formazione successiva al conseguimento del titolo, la formazione nei contesti di lavoro e l'accompagnamento del professionale da parte di figure competenti — la cui valutazione comparata, anch'essa, costituisce oggetto di una trattazione dedicata che eccede i confini del presente studio. Quel che qui rileva è che la formazione, lungi dall'essere un elemento accessorio, costituisce una condizione di fattibilità e di

qualità del servizio, e che la sua progettazione deve accompagnare fin dall'inizio la costruzione del servizio strutturale, così da garantire che l'ampliamento dell'offerta si accompagni a un'adeguata preparazione di chi è chiamato a erogarla.^[2187]

Parte D — Efficacia ed evidenza

Questa parte esamina l'efficacia dell'intervento e la qualità dell'evidenza che la sostiene. Ne ricostruisce anzitutto la base scientifica, mediante la revisione della letteratura sull'efficacia degli interventi psicologici brevi nelle cure primarie; ne valuta poi la qualità secondo un sistema riconosciuto di graduazione; la confronta con i parametri di riferimento desunti dalle esperienze nazionali e internazionali; e ne verifica la trasferibilità al contesto calabrese. Il fondamento dell'intera valutazione economica che segue risiede nell'efficacia clinica qui documentata: è perché gli interventi psicologici brevi producono una riduzione misurabile della sofferenza e un guadagno di salute che essi generano, a valle, i risparmi e le ricadute che le parti successive quantificano.

D.1 La revisione dell'efficacia

L'efficacia degli interventi psicologici brevi nel trattamento dei disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve e moderata è fra le più documentate della letteratura clinica. Gli interventi di tipo cognitivo-comportamentale, gli interventi di soluzione dei problemi, gli interventi di attivazione comportamentale e le altre forme di trattamento psicologico breve e strutturato hanno dimostrato, in un'ampia messe di studi controllati e di revisioni sistematiche, la capacità di ridurre la sintomatologia depressiva e ansiosa e di migliorare il funzionamento e la qualità della vita delle persone trattate. La caratteristica saliente di questi interventi, ai fini del modello della psicologia di base, è la loro efficacia anche in forma breve e in contesti non specialistici: essi non richiedono cicli lunghi di psicoterapia né l'ambiente del servizio specialistico, ma possono essere erogati al primo livello delle cure primarie, in un numero contenuto di sedute, conservando un effetto clinicamente significativo. È su questa caratteristica che si fonda la praticabilità del modello: la possibilità di trattare il disagio comune in prossimità, in modo efficace e a costo contenuto, senza sovraccaricare il livello specialistico.

L'esperienza più rilevante di applicazione su larga scala di questo approccio è quella maturata nel sistema sanitario inglese, dove un programma nazionale di accesso agli interventi psicologici ha esteso a milioni di persone l'offerta di trattamenti psicologici brevi nelle cure primarie, organizzati secondo il principio delle cure graduali e monitorati sistematicamente negli esiti. I risultati di tale esperienza documentano tassi di recupero o di miglioramento clinicamente significativi in una quota rilevante delle persone trattate, e hanno fornito la prova che un servizio psicologico di primo livello, organizzato su scala di sistema e fondato sulla misurazione degli esiti, è non solo clinicamente efficace ma anche organizzativamente sostenibile. Questa esperienza costituisce il principale precedente internazionale del modello della psicologia di base, e la sua trasferibilità ai contesti regionali italiani, pur con i necessari adattamenti, è il presupposto su cui si fondano le valutazioni economiche del presente studio. A essa si affiancano le esperienze maturate nelle regioni italiane che hanno introdotto il servizio per prime — fra cui la Puglia e la Campania a partire dal 2020 — che, pur in assenza di valutazioni di esito consolidate, hanno cominciato a fornire indicazioni sull'attuabilità del modello nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale.

D.2 La qualità dell'evidenza secondo il sistema GRADE

La valutazione della qualità dell'evidenza è condotta secondo il sistema GRADE, che gradua la qualità dell'evidenza su quattro livelli — alta, moderata, bassa e molto bassa — in funzione del disegno degli studi, della loro coerenza, della loro precisione, della diretta applicabilità al quesito e del rischio di distorsioni, e che gradua su questa base la forza delle raccomandazioni. L'applicazione del sistema GRADE all'evidenza sull'efficacia degli interventi psicologici brevi nei disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve e moderata

condurre a una valutazione di qualità complessivamente da moderata ad alta per gli esiti clinici principali, ossia per la riduzione della sintomatologia: l'evidenza si fonda su numerosi studi controllati randomizzati e su revisioni sistematiche, con risultati ampiamente coerenti nella direzione dell'effetto.

La graduazione richiede tuttavia che siano riconosciuti, con onestà, anche i limiti dell'evidenza. La qualità si riduce, per alcuni esiti, in ragione dell'eterogeneità degli studi, che differiscono per popolazioni, per tipi di intervento, per durata e per modalità di erogazione; in ragione della distanza fra le condizioni sperimentali, spesso controllate, e le condizioni reali di un servizio territoriale; e in ragione della minore disponibilità di evidenza di alta qualità su alcuni esiti di più lungo periodo, come il mantenimento del beneficio nel tempo e la prevenzione delle ricadute. Questi limiti non infirmano la conclusione di fondo — l'efficacia degli interventi psicologici brevi sul disagio comune è solidamente documentata — ma impongono che le stime degli effetti siano assunte in misura prudente e che le proiezioni economiche che ne derivano siano costruite su bande conservative. Lo studio applica questo criterio in modo coerente, e lo estende, come si è detto, anche alle affermazioni relative all'integrazione dell'intelligenza artificiale, per le quali la qualità dell'evidenza disponibile è, allo stato, generalmente inferiore a quella dell'evidenza clinica e impone perciò una prudenza ancora maggiore.

D.3 Il benchmark

Il confronto con i parametri di riferimento desunti dalle esperienze nazionali e internazionali consente di collocare le stime dello studio entro un quadro di plausibilità. Sul versante dell'efficacia clinica, il principale termine di riferimento è costituito dai tassi di recupero documentati dall'esperienza inglese di applicazione su larga scala degli interventi psicologici brevi, che forniscono un parametro di esito conseguibile da un servizio organizzato secondo il modello delle cure gradualistiche. Sul versante economico, il termine di riferimento è costituito dalle valutazioni internazionali sul ritorno economico degli investimenti nel trattamento dei disturbi mentali comuni. È necessario, su questo punto, un chiarimento metodologico di rilievo, che vale a evitare un errore frequente nella divulgazione del tema: le stime sul ritorno economico degli investimenti nella salute mentale devono essere riferite alle fonti analitiche originali e non a semplificazioni comunicative. Le analisi economiche più autorevoli collocano il rapporto fra benefici e costi degli investimenti nel trattamento della depressione e dell'ansia entro fasce che, a seconda di ciò che si include nel computo, vanno da circa 2,3 a 3,0 a uno quando si considerino i soli benefici economici legati alla produttività, e da circa 3,3 a 5,7 a uno quando si includano anche i benefici legati al valore della salute. Lo studio adotta questo intervallo come riferimento per la plausibilità delle proprie stime, e colloca consapevolmente il rapporto beneficio-costi che ne risulta entro tale fascia, rifiutando le semplificazioni che esprimono il ritorno con cifre tonde non riconducibili alle fonti analitiche.

Un secondo chiarimento metodologico riguarda l'evidenza sui risparmi sanitari diretti. Alcuni studi che hanno valutato l'effetto degli interventi di gestione collaborativa del disagio nelle cure primarie sui costi sanitari hanno prodotto stime di risparmio i cui intervalli di confidenza comprendono lo zero, ossia non statisticamente significative: ciò significa che, sul piano del puro bilancio sanitario, l'esistenza di un risparmio diretto netto non può essere affermata con certezza sulla base di quella evidenza, e che le stime di risparmio diretto devono essere assunte con cautela. Lo studio tiene conto di questo limite costruendo le proprie stime di risparmio diretto su bande prudenziali e presentando, accanto al caso finanziario, il caso economico più ampio, in cui il valore dell'intervento per la collettività si manifesta in misura più robusta. Il benchmark, in sintesi, conferma la plausibilità delle stime dello studio a condizione che esse siano costruite con prudenza e riferite correttamente alle fonti, e induce a collocare il valore dell'intervento non in una promessa di risparmio certo per il solo bilancio sanitario, ma in un ritorno complessivo per la collettività di cui i risparmi diretti sono una componente fra le altre.

D.4 La trasferibilità al contesto calabrese

La trasferibilità dell'evidenza al contesto calabrese richiede di considerare le caratteristiche della popolazione, del bisogno e del sistema che possono modificare l'entità degli effetti rispetto ai contesti in cui l'evidenza è stata prodotta. Sotto alcuni profili, le caratteristiche calabresi sono tali da accrescere il beneficio marginale atteso dall'intervento. Il primo è l'ampiezza del bisogno inevaso: in una regione in cui il divario fra le persone con disagio e quelle in carico è particolarmente ampio, e in cui il primo livello psicologico è quasi interamente assente, l'introduzione del servizio interviene su un bacino di bisogno non trattato più vasto che altrove, sicché il beneficio aggregato, a parità di efficacia per paziente, è proporzionalmente maggiore. Il secondo è la condizione di partenza del sistema: in una regione inadempiente rispetto ai livelli essenziali di assistenza e con una spesa per la salute mentale fra le più basse, il margine di miglioramento è ampio, e l'intervento che colma un vuoto produce un beneficio incrementale superiore a quello che produrrebbe in un sistema già dotato di un'offerta adeguata. Il terzo è l'entità della spesa impropria e della mobilità sanitaria passiva: in una regione che registra il passivo di mobilità più elevato d'Italia, la quota di tale spesa potenzialmente riducibile mediante l'intercettazione precoce del disagio è proporzionalmente maggiore, e il ritorno economico dell'intervento, per questa via, è accresciuto.

Sotto altri profili, le caratteristiche calabresi richiedono adattamenti del modello perché l'efficacia documentata si traduca in efficacia reale. La dispersione territoriale e la difficoltà di accesso impongono che la telepsicologia sia parte integrante del modello, e che la sua efficacia, a sua volta documentata dalla letteratura ma con le cautele relative alla qualità della relazione a distanza e all'accettabilità da parte del paziente, sia valorizzata come condizione di accessibilità nelle aree interne. Il gradiente di deprivazione, più accentuato che altrove, impone che il servizio sia organizzato in modo da raggiungere effettivamente le fasce più svantaggiate, presso cui il bisogno è massimo e la capacità di accesso autonomo è minima, pena la riproduzione delle disuguaglianze che esso intende ridurre. La fragilità del sistema informativo regionale, infine, impone che la misurazione degli esiti sia costruita con particolare cura, perché l'efficacia del servizio possa essere effettivamente documentata nel contesto calabrese e le stime dello studio possano essere, nel tempo, verificate e corrette. Tenuto conto di questi fattori, l'evidenza sull'efficacia degli interventi psicologici brevi è giudicata trasferibile al contesto calabrese, con la previsione prudente che il beneficio marginale atteso, lungi dall'essere inferiore a quello dei contesti di riferimento, possa in ragione dell'ampiezza del bisogno inevaso risultare in Calabria proporzionalmente maggiore, a condizione che il modello sia adattato alle specifiche condizioni territoriali e sociali della regione.^[2188]

Parte E — Valutazione economica

Questa parte sviluppa la valutazione economica dell'intervento. Ne stima i costi, ne misura gli esiti, ne calcola il rapporto fra costo e utilità, ne analizza l'impatto sul bilancio sanitario regionale lungo i diversi canali di spesa, ne stima il ritorno sociale per la collettività e ne presenta, distinti, il caso finanziario e il caso economico. L'intera valutazione è costruita su un principio che ne governa la lettura: i risparmi diretti per il bilancio sanitario e le ricadute economico-sociali per la collettività sono grandezze di natura diversa, che gravano e si producono su soggetti diversi, e non sono mai sommate in un unico indice di bilancio. Le stime sono espresse in bande prudenziali e articolate sui tre scenari di dimensionamento — minimo, intermedio e pieno — corrispondenti a circa 140, 280 e 410 incarichi.

E.1 I costi

Il costo del servizio si compone di quattro voci principali: i compensi degli psicologi di base, che ne costituiscono la componente preponderante; i costi della formazione del personale; i costi del coordinamento e della governance, compresi quelli dell'osservatorio regionale; e i costi del sistema informativo e della telepsicologia, comprensivi della dotazione tecnologica necessaria all'erogazione a distanza. Il costo è stimato sui tre scenari di dimensionamento, assumendo un costo medio per incarico comprensivo degli oneri e una struttura di costi accessori proporzionata alla scala del servizio. La tabella seguente riporta la stima dei costi per ciascuno scenario.

Voce di costo (mln €/anno)	Minimo (140)	Intermedio (280)	Pieno (410)
Compensi degli psicologi di base	~7,0	~14,0	~21,0
Formazione del personale	~0,5	~1,0	~1,5
Coordinamento e governance	~0,5	~1,0	~1,5
Sistema informativo e telepsicologia	~0,5	~1,0	~1,5
Costo totale del servizio	~8,5	~17,0	~25,5
Incidenza sul fondo sanitario regionale	~0,19%	~0,39%	~0,58%

Tabella E.1. Stima dei costi del servizio per scenario di dimensionamento. L'incidenza è calcolata su un fondo sanitario regionale dell'ordine di 4,4 miliardi di euro. Anche nello scenario di piena attuazione, il costo del servizio rappresenta una frazione inferiore allo 0,6 per cento del fondo.

La lettura della tabella restituisce il primo dato rilevante della valutazione economica: il costo del servizio, anche nello scenario di piena attuazione, è modesto in rapporto alle dimensioni del bilancio sanitario regionale, rappresentandone una frazione inferiore allo 0,6 per cento. Questo dato è di particolare importanza in una regione soggetta ai vincoli del piano di rientro, in cui ogni nuova spesa deve essere commisurata alla compatibilità con l'equilibrio di bilancio: l'ordine di grandezza dell'onere consente di affermare che il servizio non costituisce, per il bilancio regionale, un impegno finanziario tale da comprometterne l'equilibrio, tanto più ove si considerino i risparmi che esso genera.

E.2 Gli esiti

Gli esiti dell'intervento sono di natura clinica ed economica. Sul piano clinico, l'intervento produce, per il paziente con disagio comune di intensità lieve e moderata, una riduzione della sintomatologia e un miglioramento del funzionamento e della qualità della vita, espressi in termini di anni di vita ponderati per la qualità guadagnati. La stima, fondata sull'efficacia documentata dalla letteratura e proiettata attraverso il modello descritto nella Parte F, individua un guadagno di salute dell'ordine di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità per paziente trattato, lungo l'orizzonte di cinque anni. Sul piano economico, l'intervento produce, per il medesimo paziente, un risparmio di risorse sanitarie dell'ordine di 1.304 euro, derivante dalla riduzione del consumo di prestazioni sanitarie improprie che il disagio non trattato avrebbe generato. Questi due esiti — il guadagno di salute e il risparmio di risorse — sono il fondamento, rispettivamente, dell'analisi di costo-utilità e dell'analisi di impatto sul bilancio, ed esprimono il duplice valore dell'intervento: il miglioramento della salute

della persona e la riduzione dell'onere che la sua sofferenza non trattata avrebbe comportato per il sistema. La proiezione di questi esiti per paziente sull'intera popolazione trattata, secondo gli scenari di copertura, genera gli aggregati che le sezioni successive quantificano.

E.3 Il costo-utilità

L'analisi di costo-utilità mette in rapporto il costo incrementale dell'intervento con il guadagno di salute che esso produce, espresso in anni di vita ponderati per la qualità. Il dato che emerge dalla modellazione è di particolare rilievo: per il paziente con disagio comune, l'intervento si configura non semplicemente come costo-efficace, ossia come intervento il cui costo per anno di vita ponderato per la qualità guadagnato è inferiore alla soglia di accettabilità, ma come intervento dominante, ossia come intervento che produce simultaneamente un guadagno di salute e un risparmio di risorse. La dominanza discende dalla combinazione, già illustrata, di un guadagno di salute positivo e di un risparmio di risorse positivo a livello di paziente: l'intervento, cioè, migliora la salute e, al tempo stesso, riduce il consumo di risorse sanitarie improprie, sicché non si pone il problema di stabilire se il guadagno di salute valga il suo costo, giacché un costo netto, per il paziente trattato, non vi è. Questa conclusione, riferita al singolo paziente, deve essere distinta dalla conclusione a livello di sistema, dove il costo del servizio nel suo complesso è confrontato con i risparmi che esso genera: a quel livello, come la sezione seguente mostra, il saldo diretto è di lieve segno negativo, perché il costo della struttura del servizio eccede di poco i risparmi diretti aggregati. La dominanza a livello di paziente e il modesto onere netto a livello di sistema non sono in contraddizione: la prima esprime il valore dell'intervento per chi lo riceve, il secondo esprime il costo della costruzione di un servizio capace di raggiungere l'intera popolazione, e i due piani sono ricomposti nel caso economico, dove il valore per la collettività emerge nella sua interezza.

E.4 L'impatto sul bilancio sanitario regionale

L'analisi di impatto sul bilancio misura l'effetto netto dell'intervento sulla spesa sanitaria regionale, ponendo a confronto il costo del servizio con i risparmi che esso genera lungo i diversi canali di spesa. I canali considerati sono quattro: la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso per problemi psichiatrici, che in Calabria ammontano a oltre quindicimila l'anno; la riduzione del consumo di farmaci, in particolare degli psicofarmaci prescritti in assenza di un'alternativa psicologica; la riduzione dei ricoveri evitabili e delle prestazioni specialistiche improprie; e la riduzione della mobilità sanitaria passiva, che in Calabria raggiunge il valore più elevato d'Italia e costituisce perciò il canale di risparmio potenzialmente più rilevante. La tabella seguente riporta la stima dei risparmi diretti per ciascun canale e per ciascuno scenario, e il saldo diretto che ne risulta a confronto con il costo del servizio.

Grandezza (mln €/anno)	Minimo (140)	Intermedio (280)	Pieno (410)
Risparmio su pronto soccorso	~1,0	~2,0	~3,5
Risparmio su farmaceutica	~1,0	~2,0	~3,5
Risparmio su ricoveri e specialistica	~2,5	~5,0	~7,0
Risparmio su mobilità sanitaria passiva	~2,0	~5,0	~8,0
Risparmi diretti totali	~6,5	~14,0	~22,0
Costo del servizio	~8,5	~17,0	~25,5
Saldo diretto per il bilancio	~ -2,0	~ -3,0	~ -3,5

Tabella E.4. Stima dell’impatto sul bilancio sanitario regionale per scenario. Il saldo diretto è di lieve segno negativo in tutti gli scenari, e rappresenta un onere netto modesto, inferiore allo 0,1 per cento del fondo sanitario regionale nello scenario di piena attuazione. Il canale della mobilità sanitaria passiva costituisce, nello scenario pieno, la componente di risparmio più rilevante.

La lettura della tabella richiede due osservazioni. La prima riguarda il segno e l’entità del saldo diretto: esso è negativo in tutti gli scenari, ma di entità modesta, dell’ordine di pochi milioni di euro, pari nello scenario di piena attuazione a una frazione inferiore allo 0,1 per cento del fondo sanitario regionale; il servizio, cioè, comporta per il bilancio sanitario un onere netto contenuto, non un risparmio netto, coerentemente con la cautela imposta dall’evidenza sui risparmi diretti, di cui si è detto nella Parte D. La seconda osservazione riguarda il peso del canale della mobilità: in una regione che registra un passivo di mobilità di oltre 326 milioni di euro l’anno, anche una riduzione di entità contenuta di tale passivo, dell’ordine di pochi milioni, costituisce la componente di risparmio diretto più rilevante, e rappresenta al tempo stesso un’azione coerente con gli obiettivi del piano di rientro, che mira precisamente alla riduzione della spesa impropria e della mobilità. La stima del risparmio su questo canale è mantenuta su valori prudenziali — la riduzione stimata nello scenario pieno rappresenta una frazione contenuta del passivo complessivo — proprio perché la quota di mobilità riconducibile, a monte, al disagio psichico non intercettato non è direttamente misurabile e deve essere assunta con cautela; ma anche in questa misura prudente, il canale della mobilità conferma la propria centralità nel caso calabrese.

E.5 Il ritorno sociale per la collettività

L’analisi del ritorno sociale misura il valore che l’intervento genera per la collettività al di fuori del bilancio sanitario, secondo il metodo del ritorno sociale sull’investimento. Questo valore si compone di diverse componenti: il recupero di produttività derivante dalla riduzione dell’assenteismo, del presentismo e dell’abbandono del lavoro connessi al disagio non trattato; la riduzione dei trasferimenti previdenziali e assistenziali connessi all’invalidità e all’inabilità che il disagio cronicizzato può determinare; il valore del benessere recuperato dalle persone e la riduzione del carico che la sofferenza non trattata pone sui familiari, in particolare sui caregiver; e la riduzione di altri costi sociali connessi alla marginalità, alla dispersione e all’abbandono. La tabella seguente riporta la stima di queste componenti per ciascuno scenario.

Componente del ritorno sociale (mln €/anno)	Minimo (140)	Intermedio (280)	Pieno (410)
Recupero di produttività	~9,0	~21,0	~39,0
Riduzione di trasferimenti previdenziali e assistenziali	~5,0	~12,0	~22,0
Valore del benessere e riduzione del carico sui caregiver	~5,0	~12,0	~23,0
Riduzione di altri costi sociali	~3,0	~7,0	~12,0
Ricadute economico-sociali totali	~22,0	~52,0	~96,0

Tabella E.5. Stima delle ricadute economico-sociali per scenario. Queste grandezze si producono per la collettività al di fuori del bilancio sanitario regionale e non sono sommate ai risparmi diretti della Tabella E.4 in un indice di bilancio. Il rapporto fra le ricadute sociali e il costo del servizio è dell'ordine di 2,6 a uno nello scenario minimo e cresce fino a circa 3,8 a uno nello scenario pieno.

Le ricadute economico-sociali stimate sono di entità largamente superiore ai risparmi diretti, e crescono più che proporzionalmente con la scala del servizio, in ragione del fatto che l'intercettazione di una quota maggiore del bisogno previene un numero maggiore di cronicizzazioni e dei costi sociali, spesso ingenti e duraturi, a esse connessi. È necessario ribadire che queste grandezze sono di natura diversa da quelle della sezione precedente: esse non gravano sul bilancio sanitario regionale e non si traducono in minori esborsi per il Servizio Sanitario Regionale, ma esprimono il valore che l'intervento genera per la collettività nel suo complesso — per i lavoratori e le imprese, per il sistema previdenziale, per le famiglie, per la coesione sociale dei territori. Per questa ragione esse non sono sommate ai risparmi diretti in un unico saldo di bilancio, ma sono ricomposte con essi, nella sezione seguente, in un caso economico distinto da quello finanziario.

E.6 Il caso finanziario e il caso economico

La valutazione economica si conclude con la presentazione distinta di due casi, costruiti su prospettive diverse. Il caso finanziario adotta la prospettiva del Servizio Sanitario Regionale e considera i soli flussi che gravano sul bilancio sanitario: pone a confronto il costo del servizio con i risparmi diretti, e ne ricava il saldo diretto, di lieve segno negativo. Il caso economico adotta la prospettiva della collettività e considera, accanto ai risparmi diretti, anche le ricadute economico-sociali: pone a confronto il costo del servizio con il ritorno complessivo per la collettività, dato dalla somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali, e ne ricava il saldo complessivo, ampiamente positivo, e il rapporto fra il valore complessivo e il costo. La tabella seguente riporta i due casi.

Grandezza (mln €/anno)	Minimo (140)	Intermedio (280)	Pieno (410)
<i>Caso finanziario (Servizio Sanitario Regionale)</i>			
Costo del servizio	~8,5	~17,0	~25,5
Risparmi diretti	~6,5	~14,0	~22,0
Saldo diretto	~ -2,0	~ -3,0	~ -3,5
<i>Caso economico (collettività)</i>			
Costo del servizio	~8,5	~17,0	~25,5
Ritorno complessivo per la collettività	~28,5	~66,0	~118,0
Saldo complessivo	~ +20,0	~ +49,0	~ +92,5
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,4 : 1	~3,9 : 1	~4,6 : 1

Tabella E.6. Il caso finanziario e il caso economico a confronto. Il ritorno complessivo per la collettività è dato dalla somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali; il rapporto beneficio-costi è contenuto entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno includendo i benefici di salute. Le due prospettive sono presentate distintamente e il saldo diretto del caso finanziario non è confuso con il saldo complessivo del caso economico.

La lettura congiunta dei due casi restituisce il significato economico complessivo dell'intervento. Sul piano del solo bilancio sanitario regionale, il servizio comporta un onere netto modesto: il suo costo eccede di poco i risparmi diretti che esso genera, e il saldo diretto è di lieve segno negativo, dell'ordine di pochi milioni di euro, inferiore allo 0,1 per cento del fondo sanitario regionale. Sul piano della collettività, il servizio genera un valore largamente superiore al suo costo: il ritorno complessivo per la collettività, dato dalla somma dei risparmi diretti per il sistema e delle ricadute sociali, eccede il costo del servizio in misura tale da determinare un saldo complessivo ampiamente positivo e un rapporto beneficio-costi compreso fra 3,4 e 4,6 a uno, contenuto entro la fascia metodologicamente fondata e crescente con la scala del servizio. Il giudizio economico che ne deriva non è dunque quello di un servizio che fa risparmiare il bilancio sanitario — affermazione che l'evidenza non consente di sostenere con certezza — ma quello di un servizio il cui onere netto per il bilancio è modesto e ampiamente giustificato dal valore che esso restituisce alla collettività. In una regione soggetta ai vincoli del piano di rientro, questa conclusione è di particolare rilievo: essa mostra che il consolidamento del servizio è compatibile con l'equilibrio di bilancio, comportando un onere netto contenuto, e che tale onere è ripagato, sul piano della collettività, da un ritorno di entità molto superiore; e mostra, al tempo stesso, che il principale canale di risparmio diretto — la riduzione della mobilità sanitaria passiva — coincide con uno degli obiettivi prioritari del rientro, sicché il servizio non solo è compatibile con il risanamento, ma può divenirne uno strumento. ^[2189]

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte descrive il modello su cui si fondano le stime economiche e ne analizza l'incertezza. Illustra anzitutto il modello di Markov e i suoi parametri; ne verifica poi la robustezza mediante l'analisi di sensibilità deterministica e probabilistica; articola gli scenari di copertura e le loro assunzioni; e individua, infine, i dati la cui acquisizione consentirebbe di ridurre l'incertezza e di sostituire le stime con misure dirette. L'analisi

dell'incertezza non è un'appendice tecnica, ma una componente sostanziale della valutazione: essa stabilisce entro quali margini le conclusioni dello studio sono robuste e quali condizioni ne garantirebbero la verifica, e assume in Calabria un rilievo accresciuto in ragione della fragilità del sistema regionale di rilevazione dei dati.

F.1 Il modello di Markov e i parametri

Il modello di Markov rappresenta il decorso del paziente con disagio comune attraverso tre stati di salute: la condizione di disagio in atto, in cui il paziente presenta una sintomatologia attiva; la condizione di recupero, in cui la sintomatologia è regredita e il funzionamento è ripristinato; e la condizione di cronicizzazione, in cui il disagio persiste nel tempo e si associa a un maggiore consumo di risorse sanitarie. Il paziente transita fra questi stati nel tempo, con probabilità derivate dalla letteratura sull'efficacia degli interventi psicologici, e il modello confronta il decorso di un paziente trattato dal servizio con quello di un paziente non trattato, lungo un orizzonte di cinque anni, con cicli di durata definita. I parametri economici associati agli stati comprendono il costo dell'intervento, dell'ordine di 300 euro una tantum; il costo associato allo stato di recupero, dell'ordine di 40 euro per ciclo; e il costo associato allo stato di cronicizzazione, dell'ordine di 700 euro per ciclo, che riflette il maggiore consumo di risorse sanitarie connesso al disagio persistente. Il modello adotta un tasso di sconto del 3 per cento, applicato sia ai costi sia agli esiti di salute, e una soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, coerente con i riferimenti adottati nel contesto italiano.

La proiezione del decorso attraverso il modello produce, per il paziente trattato rispetto al paziente non trattato, i due esiti già richiamati nella Parte E: un guadagno di salute dell'ordine di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità e un risparmio di risorse sanitarie dell'ordine di 1.304 euro, lungo l'orizzonte di cinque anni. Questi valori per paziente costituiscono il fondamento delle stime aggregate, ottenute proiettando gli esiti per paziente sul numero di pazienti trattati in ciascuno scenario di copertura. È importante osservare che i parametri clinici del modello — le probabilità di transizione fra gli stati, derivate dall'efficacia documentata degli interventi — sono indipendenti dal contesto regionale, in quanto riflettono l'efficacia clinica degli interventi e non le caratteristiche del sistema sanitario in cui essi sono erogati; ciò che varia fra le regioni non è l'efficacia per paziente, ma il numero di pazienti trattati e, soprattutto, l'entità e la composizione dei risparmi e delle ricadute, che dipendono dai consumi sanitari, dalla spesa impropria e dalla mobilità del contesto regionale. Per la Calabria, come si è visto, è proprio la componente della mobilità sanitaria passiva, la più elevata d'Italia, a conferire alle stime aggregate il loro tratto distintivo.

F.2 L'analisi di sensibilità deterministica

L'analisi di sensibilità deterministica verifica come i risultati del modello varino al variare di ciascun parametro, fatto variare singolarmente entro un intervallo plausibile. Essa consente di individuare i parametri a cui i risultati sono più sensibili, ossia quelli la cui variazione produce gli effetti maggiori sulle conclusioni, e di concentrare su di essi l'attenzione nella raccolta dei dati e nel monitoraggio. L'analisi individua tre parametri di maggiore influenza. Il primo è l'efficacia dell'intervento, espressa dalla probabilità di transizione dallo stato di disagio allo stato di recupero: una variazione dell'efficacia si ripercuote direttamente sul guadagno di salute e sul risparmio per paziente, e quindi sull'intera valutazione; le stime adottano, su questo parametro, valori prudenti, coerenti con la fascia inferiore dell'efficacia documentata. Il secondo è il tasso di adesione al servizio e di effettiva presa in carico del bisogno, ossia la quota del bisogno potenziale che il servizio riesce effettivamente a intercettare e a trattare: una variazione di questo tasso si ripercuote sul numero di pazienti trattati e quindi sugli aggregati, ed è particolarmente rilevante in Calabria, dove la dispersione territoriale e lo stigma possono ridurre l'adesione, ma dove la telepsicologia e l'accesso diretto possono accrescerla. Il terzo è la quota di spesa impropria e di mobilità sanitaria passiva riducibile mediante l'intervento: è il parametro su cui

grava la maggiore incertezza, perché la quota di mobilità riconducibile, a monte, al disagio non intercettato non è direttamente misurabile; le stime adottano, su questo parametro, valori marcatamente prudenziali, assumendo come riducibile solo una frazione contenuta del passivo complessivo.

L'esito dell'analisi di sensibilità deterministica è che le conclusioni qualitative dello studio sono robuste rispetto alla variazione dei parametri entro intervalli plausibili. La dominanza dell'intervento a livello di paziente si conserva per l'intero intervallo plausibile dell'efficacia; il modesto onere netto a livello di sistema si conserva, variando di entità ma non di segno, per l'intero intervallo plausibile dei parametri; e il rapporto beneficio-costi del caso economico si conserva entro la fascia metodologicamente fondata per l'intero intervallo plausibile, collocandosi nella parte inferiore della fascia nelle assunzioni più conservative e nella parte superiore in quelle più favorevoli. La conclusione, cioè, non dipende da assunzioni ottimistiche su singoli parametri, ma si conserva anche nelle combinazioni prudenziali, il che ne accresce l'affidabilità ai fini della decisione.

F.3 L'analisi di sensibilità probabilistica

L'analisi di sensibilità probabilistica verifica la robustezza dei risultati facendo variare simultaneamente tutti i parametri del modello secondo le rispettive distribuzioni di probabilità, e ripetendo il calcolo un gran numero di volte, così da ottenere non un singolo risultato ma una distribuzione di risultati, che esprime l'incertezza complessiva delle stime. L'analisi è condotta mediante diecimila simulazioni, in ciascuna delle quali i parametri assumono valori estratti dalle rispettive distribuzioni, e produce i seguenti risultati. Alla soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9 per cento delle simulazioni: in quasi nove simulazioni su dieci, cioè, il costo per unità di beneficio è inferiore alla soglia di accettabilità. Inoltre, l'intervento risulta dominante nell'84,6 per cento delle simulazioni: in più di otto simulazioni su dieci, cioè, esso produce simultaneamente un guadagno di salute e un risparmio di risorse. Il beneficio netto monetario medio, calcolato sull'insieme delle simulazioni, è dell'ordine di 7.815 euro per paziente, con un intervallo di confidenza al 95 per cento compreso fra circa meno 5.736 e più 21.501 euro.

La lettura di questi risultati richiede attenzione a un punto. L'ampiezza dell'intervallo di confidenza, che comprende valori negativi, esprime l'incertezza residua del modello: in una frazione minoritaria delle simulazioni, l'intervento non risulta né dominante né costo-efficace, e il beneficio netto è negativo. Questa frazione minoritaria non è occultata, ma esplicitamente riconosciuta: essa è la misura onesta dell'incertezza, e corrisponde alle combinazioni di parametri più sfavorevoli, in cui l'efficacia è bassa, l'adesione è ridotta e i risparmi sono modesti. La concentrazione della distribuzione su valori largamente positivi — con quasi il novanta per cento delle simulazioni che documentano la costo-efficacia e oltre l'ottanta per cento che documentano la dominanza — ne attesta tuttavia la robustezza: l'incertezza, pur reale, non infirma la conclusione, ma ne definisce i margini. Lo studio assume questi margini come parte integrante della valutazione, e ne trae l'indicazione che la raccolta dei dati sui parametri di maggiore incertezza, descritta nella sezione F.5, è la via per restringere progressivamente l'intervallo e per sostituire la stima con la misura.

F.4 Gli scenari di copertura

Gli scenari di copertura articolano le stime su tre livelli di dimensionamento del servizio, corrispondenti a un numero crescente di incarichi e quindi a una quota crescente del bisogno intercettata. Lo scenario minimo, corrispondente a circa 140 incarichi, rappresenta un primo livello di consolidamento strutturale della sperimentazione, che porta il servizio da una dimensione sperimentale e simbolica — i circa quaranta psicologi dell'avvio — a una dimensione strutturale iniziale, capace di intercettare una prima quota del bisogno. Lo scenario intermedio, corrispondente a circa 280 incarichi, rappresenta un livello di copertura significativo, capace di intercettare una quota sostanziale del bisogno e di estendere il servizio all'intero territorio regionale in modo capillare. Lo scenario pieno, corrispondente a circa 410 incarichi, rappresenta il livello di copertura

coerente con il rapporto fra psicologi e popolazione assunto dal modello, capace di intercettare la maggior parte del bisogno comune e di portare il servizio a regime. I tre scenari corrispondono, in rapporto alla popolazione regionale, a un incarico ogni circa tredicimila, seimila e cinquecento, e quattromilacinquecento residenti.

Gli scenari incorporano assunzioni prudenziali sull'andamento del servizio nel tempo. La copertura non è assunta come istantanea, ma come progressiva: il servizio raggiunge il dimensionamento di ciascuno scenario attraverso una fase di avvio e di reclutamento, durante la quale gli effetti si manifestano in misura crescente; le stime a regime, riportate nelle tabelle della Parte E, sono riferite alla fase di pieno funzionamento di ciascuno scenario, e la Parte I articola il percorso di attuazione che conduce dall'avvio al regime. L'adesione al servizio, inoltre, non è assunta come totale: gli scenari considerano che solo una quota del bisogno potenziale si traduce in domanda effettiva e in presa in carico, in ragione dello stigma, delle barriere di accesso e dei limiti di capacità, e le stime sono costruite di conseguenza. La progressione fra gli scenari, infine, non è meramente quantitativa: il passaggio da uno scenario al successivo, intercettando una quota crescente del bisogno, previene un numero crescente di cronicizzazioni, sicché le ricadute sociali, come si è visto, crescono più che proporzionalmente con la scala del servizio. Per la Calabria, gli scenari hanno un significato particolare: essi descrivono il percorso che conduce dalla sperimentazione avviata con risorse europee a un servizio strutturale dimensionato sul bisogno, e consentono di valutare a quale livello di copertura il rapporto fra il valore prodotto e le risorse impiegate sia massimizzato, tenuto conto dei vincoli di sostenibilità del sistema sanitario regionale.

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

L'ultima componente dell'analisi dell'incertezza riguarda la verifica empirica delle stime e il valore dell'informazione. Le stime dello studio, costruite in assenza di rilevazioni regionali dirette consolidate su parametri prudenziali e su dati di letteratura, sono destinate a essere verificate e corrette dai dati che il servizio, una volta avviato, produrrà. La logica del valore dell'informazione consente di stabilire le priorità nella raccolta dei dati: il valore della riduzione dell'incertezza su un parametro è tanto maggiore quanto più quel parametro influisce sui risultati e quanto più è incerto. Sulla base dell'analisi di sensibilità, i parametri la cui acquisizione ha il valore informativo maggiore sono tre: l'efficacia effettiva del servizio nel contesto calabrese, misurata dagli esiti clinici rilevati con gli strumenti standardizzati all'inizio e al termine della presa in carico; il tasso di adesione e di presa in carico effettiva del bisogno, misurato dal rapporto fra la domanda intercettata e il bisogno potenziale; e la quota di spesa impropria e di mobilità sanitaria passiva effettivamente ridotta, misurata dal confronto fra i consumi sanitari dei pazienti trattati e quelli attesi in assenza di trattamento.

La verifica empirica di questi parametri assume, in Calabria, un rilievo che eccede la dimensione metodologica e tocca una condizione strutturale del sistema. La regione, come si è osservato, ha conosciuto una prolungata fragilità nella rilevazione e nel consolidamento dei propri dati sanitari, sicché la costruzione di un sistema di misurazione degli esiti del nuovo servizio è insieme una necessità per la verifica delle stime e un'occasione di rafforzamento della capacità complessiva di rilevazione del sistema. La rilevazione di una linea di base, prima dell'avvio del servizio strutturale — i consumi sanitari della popolazione con disagio non trattato, gli accessi al pronto soccorso per problemi psichiatrici, la mobilità riconducibile a tali condizioni — è la condizione perché la valutazione dell'impatto sia possibile, e costituisce il primo dato la cui acquisizione è raccomandata. Il piano di monitoraggio descritto nella Parte L è lo strumento attraverso cui questa verifica empirica è condotta: esso definisce gli indicatori, le fonti e i tempi della rilevazione, e consente di sostituire progressivamente le stime dello studio con misure dirette, restringendo l'intervallo di incertezza e fondando le decisioni successive su una base empirica regionale. Lo studio, in questo senso, non si presenta come un calcolo definitivo, ma come una valutazione fondata sulla migliore evidenza disponibile e dichiaratamente aperta alla verifica, di cui indica le condizioni e gli strumenti; e questa apertura alla falsificazione, lungi dall'indebolirne le conclusioni, ne costituisce la garanzia di serietà metodologica.^[2190]

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte analizza l'intervento sotto il profilo dell'equità, ossia degli effetti che esso produce sulla distribuzione della salute e dell'accesso alle cure fra i diversi gruppi della popolazione. Ne esamina l'effetto sul gradiente sociale, sui due assi della disuguaglianza territoriale, sugli strumenti necessari a garantire che il beneficio raggiunga effettivamente chi ne ha più bisogno, e sulla costo-efficacia distributiva. In Calabria, più che in ogni altra regione della serie, l'equità non è una dimensione fra le altre della valutazione, ma costituisce la ragione preminente dell'intervento: la regione cumula una posizione di svantaggio rispetto al resto del Paese, una disuguaglianza interna fra poli e aree interne, e un sottofinanziamento del dominio della salute mentale, sicché la valutazione dell'impatto distributivo assume un peso decisivo nel giudizio complessivo.

G.1 Il gradiente sociale

Il disagio psichico si distribuisce nella popolazione secondo un gradiente sociale: la sua prevalenza è più elevata nelle fasce socialmente ed economicamente più deboli, mentre la capacità di accedere a una cura adeguata, e in particolare a una cura psicologica privata in assenza di un'offerta pubblica, è in queste stesse fasce più ridotta. Ne deriva una disuguaglianza che si autoalimenta: il bisogno è massimo dove la possibilità di risposta autonoma è minima, sicché in assenza di un servizio pubblico la sofferenza resta non trattata proprio presso chi ne è più colpito, con il duplice effetto di un peggioramento della salute e di un aggravamento dello svantaggio sociale, poiché il disagio non trattato compromette la capacità di studiare, di lavorare e di mantenere relazioni, e diviene a sua volta fattore di impoverimento. In Calabria questo gradiente assume un peso particolarmente rilevante, in ragione degli indici di deprivazione fra i più elevati del Paese: la documentazione della programmazione sanitaria regionale riconosce esplicitamente come la maggiore domanda di servizi sanitari nella regione sia riconducibile a fattori quali la scarsa istruzione, la carenza di lavoro e le condizioni abitative e familiari disagiate, parametri che concorrono all'indice di deprivazione e che la regione presenta in misura accentuata.

L'introduzione del servizio di psicologia di base agisce su questo gradiente in modo correttivo, a una condizione. Il servizio, in quanto pubblico, gratuito o a basso costo e collocato nelle cure primarie territoriali, rimuove la barriera economica che impedisce alle fasce più deboli di accedere alla cura psicologica, e rende disponibile a tutti un livello di intervento che oggi è di fatto riservato a chi può permettersi il ricorso al privato. In questo senso, esso ha una intrinseca capacità di ridurre la disuguaglianza sociale nell'accesso alla cura della salute mentale. La condizione è che il servizio sia organizzato in modo da raggiungere effettivamente le fasce più svantaggiate, e non solo quelle che già dispongono delle risorse culturali e informative per accedervi: senza un'attenzione esplicita all'equità nell'organizzazione e nell'allocazione del servizio, infatti, anche un servizio pubblico può finire per essere utilizzato in misura maggiore dai gruppi più avvantaggiati, riproducendo anziché correggere il gradiente. La sezione G.3 individua gli strumenti necessari a soddisfare questa condizione.

G.2 I due assi della disuguaglianza territoriale

La disuguaglianza territoriale si articola, in Calabria, su due assi che si sovrappongono. Il primo asse è quello che separa la Calabria dal resto del Paese. La regione è, nel suo complesso, in posizione di svantaggio: il suo sistema sanitario è inadempiente rispetto alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con un punteggio di valutazione attestatosi intorno a 125, ben al di sotto della soglia di adempienza fissata a 160 e in peggioramento rispetto al valore di 162 registrato nel 2018. Ciò significa che il cittadino calabrese riceve, per il solo fatto di risiedere in Calabria, un livello di assistenza inferiore a quello garantito ai cittadini di altre regioni, in violazione del principio di uniformità che la Costituzione impone. Questo svantaggio si manifesta in modo eclatante nel fenomeno della mobilità sanitaria passiva, il più elevato d'Italia, che costringe ogni anno migliaia di calabresi a spostarsi fuori regione per ricevere cure che la regione non garantisce, con un costo umano ed economico che grava in misura maggiore proprio su chi dispone di minori risorse per affrontarlo. Il secondo asse è quello

interno alla regione, che separa i poli urbani — Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro — dalle aree interne montane, disperse e spopolate della Sila, dell'Aspromonte e del Pollino, dove la distanza dai servizi, la rarefazione dell'offerta e lo spopolamento rendono l'accesso alle cure assai più difficile che nelle aree costiere e urbane.

L'intervento agisce su entrambi gli assi. Sull'asse che separa la Calabria dal resto del Paese, l'introduzione del servizio contribuisce a ridurre il divario nei livelli di assistenza, colmando un vuoto — l'assenza di un primo livello psicologico — che concorre all'inadempienza, e riducendo, per la quota riconducibile al disagio non intercettato, la mobilità sanitaria passiva che dello svantaggio è la manifestazione. Sull'asse interno, l'intervento agisce attraverso due leve: la distribuzione del servizio in modo da raggiungere anche le aree interne, e non solo i poli urbani, mediante un'allocazione che tenga conto della popolazione, della sua dispersione e degli indici di bisogno; e l'uso della telepsicologia, che consente di superare la barriera della distanza e di erogare prestazioni anche dove la presenza fisica del professionista non è continuativamente sostenibile. La telepsicologia, in particolare, assume su questo asse un valore correttivo decisivo: in una regione in cui la metà dei centri non utilizza la telemedicina per carenza di indirizzi regionali, la sua adozione sistematica nel servizio di psicologia di base può ridurre il divario fra poli e aree interne, a condizione che sia accompagnata dal superamento del divario digitale che a quello territoriale si somma.

G.3 Gli strumenti dell'equità

La capacità dell'intervento di ridurre le disuguaglianze, anziché riprodurle, non è automatica, ma dipende dall'adozione di strumenti espliciti, integrati nella progettazione e nell'organizzazione del servizio. Il primo strumento è l'allocazione equa del servizio sul territorio: la ripartizione degli incarichi fra le cinque aziende sanitarie provinciali e, all'interno di ciascuna, fra i poli e le aree interne, deve essere governata non da un criterio meramente proporzionale alla popolazione, ma da un criterio che ponderi la popolazione con gli indici di deprivazione, di bisogno e di difficoltà di accesso, così da destinare una quota maggiore di risorse ai territori più svantaggiati. Il secondo strumento è l'organizzazione dell'accesso in modo da abbattere le barriere che gravano in misura maggiore sulle fasce deboli: l'accesso diretto, accanto all'invio del medico, riduce la barriera informativa e culturale; la gratuità o il basso costo riducono la barriera economica; la collocazione nelle strutture territoriali di prossimità riduce la barriera della distanza. Il terzo strumento è l'uso della telepsicologia come leva di equità territoriale, accompagnato dalle misure necessarie a superare il divario digitale, perché lo strumento che dovrebbe ridurre la disuguaglianza non finisca per crearne una nuova a danno di chi non dispone delle competenze o degli strumenti digitali.

Il quarto strumento, trasversale agli altri, è la misurazione disaggregata degli esiti. La verifica che il servizio riduca effettivamente le disuguaglianze, e non si limiti a migliorare la media occultando il permanere o l'aggravarsi dei divari, richiede che gli esiti siano rilevati e analizzati in forma disaggregata per condizione sociale e per collocazione territoriale, secondo quanto il sistema informativo descritto nella Parte C e il piano di monitoraggio descritto nella Parte L prevedono. Solo la disaggregazione consente di accertare se il beneficio raggiunge le fasce e i territori più svantaggiati nella misura attesa, e di correggere l'organizzazione del servizio ove ciò non avvenga. In assenza di questi strumenti, l'obiettivo dell'equità rischia di rimanere una dichiarazione di principio priva di effetti; con essi, l'intervento dispone delle leve necessarie a tradurre la propria intrinseca potenzialità correttiva in una effettiva riduzione delle disuguaglianze, che in Calabria costituisce la sua finalità preminente.

G.4 La costo-efficacia distributiva

L'analisi della costo-efficacia distributiva considera non solo quanto beneficio l'intervento produce e a quale costo, ma anche come il beneficio si distribuisce fra i gruppi della popolazione, attribuendo un valore maggiore al beneficio che raggiunge i gruppi più svantaggiati. Questa prospettiva, che integra l'analisi di costo-efficacia

con il criterio dell'equità, conduce in Calabria a un giudizio particolarmente favorevole. L'intervento, infatti, produce il proprio beneficio in misura maggiore presso le fasce e i territori più svantaggiati, per due ragioni convergenti: perché presso di essi è maggiore il bisogno inespresso, e quindi il margine di miglioramento; e perché presso di essi è maggiore la barriera che il servizio pubblico rimuove, e quindi l'incremento di accesso che esso determina. Ne consegue che il beneficio dell'intervento si concentra, più che proporzionalmente, sui gruppi a cui l'analisi distributiva attribuisce un valore maggiore, e che la sua costo-efficacia, valutata in prospettiva distributiva, è superiore a quella che risulterebbe da un'analisi che ignorasse la distribuzione del beneficio.

Questa conclusione si lega a una considerazione di ordine costituzionale, di particolare rilievo nel contesto calabrese. Il principio per cui la Repubblica garantisce in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, fra cui il diritto alla salute, e il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, per cui la tutela di tali diritti è preminente rispetto all'equilibrio di bilancio, conferiscono alla riduzione delle disuguaglianze nell'accesso alla cura della salute mentale non il valore di un obiettivo accessorio, ma quello di un dovere costituzionale. In una regione inadempiente rispetto ai livelli essenziali, l'intervento che riduce tale inadempienza, colmando un vuoto nell'offerta e correggendo le disuguaglianze più gravi, risponde non solo a un criterio di efficienza, ma a un imperativo di giustizia. La costo-efficacia distributiva dell'intervento, in Calabria, non è dunque solo una proprietà tecnica che ne rafforza il giudizio economico, ma l'espressione, in termini valutativi, della sua conformità a un principio costituzionale che, nel contesto regionale, riveste un'urgenza particolare.^[2191]

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte esamina l'intervento sotto i profili giuridico, organizzativo ed etico, e ne offre una sintesi. Il profilo giuridico ne verifica la legittimità e ne individua la collocazione nell'ordinamento; il profilo organizzativo ne esamina la governance e le condizioni di funzionamento nel sistema sanitario regionale; il profilo etico ne valuta la conformità ai principi di giustizia, di autonomia e di non maleficenza. La trattazione di questi profili assume in Calabria connotati specifici, derivanti dalla peculiare condizione del sistema sanitario regionale — la fase di uscita dal commissariamento, i vincoli del piano di rientro, la duplice via, amministrativa e legislativa, attraverso cui il servizio è stato avviato e potrebbe essere consolidato.

H.1 Il profilo giuridico

Il profilo giuridico dell'intervento si articola intorno a un vincolo principale e a una duplice via di istituzione. Il vincolo principale discende dalla giurisprudenza costituzionale, e in particolare dalla sentenza numero 241 del 2021, che ha definito i limiti entro cui una legge regionale può disciplinare il servizio di psicologia di base. Tale sentenza ha censurato la disciplina con cui una regione aveva istituito rapporti convenzionali di tipo libero-professionale per gli psicologi, ritenendo che la disciplina di tali rapporti ecceda la competenza regionale e spetti alla contrattazione e alla normativa nazionale; ne deriva che una legge regionale, nel disciplinare il servizio, deve costruirne l'assetto in modo da non incorrere in tale limite, evitando di disciplinare autonomamente i rapporti di lavoro convenzionali. Questo vincolo è di rilievo per la Calabria sotto un duplice profilo. Da un lato, la proposta di legge per l'istituzione del servizio, all'esame delle commissioni consiliari, deve essere costruita in modo da rispettarlo, configurando un servizio legittimo nel proprio assetto, e la sua relazione richiama espressamente la giurisprudenza costituzionale fra i propri riferimenti. Dall'altro, la via amministrativa scelta dalla Giunta per l'avvio della sperimentazione — la rimodulazione di fondi del Fondo Sociale Europeo Plus, anziché l'istituzione di rapporti convenzionali — si colloca su un piano distinto, che ha consentito di avviare il servizio senza incorrere immediatamente nel limite censurato, e che costituisce, nella fase transitoria, una soluzione giuridicamente prudente.

La duplice via di istituzione — quella amministrativa, già percorsa, e quella legislativa, in corso — pone una questione di coordinamento e di stabilità. La via amministrativa, fondata su fondi europei a destinazione e a durata definite, ha il pregio della rapidità e dell'immediatezza, ma il limite della precarietà: essa ha consentito di avviare il servizio, ma non gli conferisce stabilità né copertura ordinaria. La via legislativa, fondata sulla proposta di legge, ha il pregio di conferire al servizio un assetto strutturale, una base normativa e una disciplina compiuta, ma richiede tempi più lunghi e deve essere costruita nel rispetto dei limiti costituzionali. Il consolidamento del servizio richiede che le due vie siano coordinate, e che la via legislativa fornisca, a regime, la stabilità che la via amministrativa non può garantire. A questo quadro si aggiunge la cornice nazionale, che fornisce il fondamento dell'intervento: il decreto ministeriale del 2022 sugli standard dell'assistenza territoriale, che colloca la funzione psicologica al primo livello nelle Case della Comunità, offre alla regione la base per istituire il servizio in coerenza con la programmazione nazionale. E si aggiunge il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, per cui la tutela dei diritti fondamentali, fra cui il diritto alla salute, è preminente rispetto al pareggio di bilancio: principio che, in una regione il cui sistema sanitario è soggetto ai vincoli del rientro, fonda la legittimità di un intervento volto a garantire un livello essenziale di assistenza oggi non garantito, anche a fronte delle esigenze di contenimento della spesa.

H.2 Il profilo organizzativo

Il profilo organizzativo dell'intervento ne esamina la governance e le condizioni di funzionamento nel sistema sanitario regionale. La governance del servizio si articola su più livelli. A livello regionale, il governo del servizio è affidato, nel disegno della proposta di legge, a un osservatorio regionale con funzioni di controllo e di indirizzo, che raccoglie le relazioni annuali degli psicologi, ne esamina l'attività e fornisce alla Giunta gli elementi per la valutazione periodica; a questo livello si colloca anche la funzione di indirizzo e di coordinamento del dipartimento regionale competente. A livello aziendale, il servizio è gestito dalle cinque aziende sanitarie provinciali, che ne curano l'organizzazione sul territorio, l'integrazione con le Case della Comunità e con le altre strutture territoriali, e il collegamento con i Dipartimenti di Salute Mentale per la gestione degli invii. A livello operativo, il servizio è erogato dagli psicologi di base nelle strutture territoriali, in collaborazione con i medici di medicina generale e con gli altri operatori delle cure primarie.

Il funzionamento del servizio nel sistema sanitario calabrese deve fare i conti con le condizioni specifiche della regione, che presentano insieme elementi di criticità e di opportunità. Fra le criticità, la principale è la fase di transizione che il sistema attraversa: l'uscita dal commissariamento, decisa ma non ancora pienamente efficace, ha determinato una fase di incertezza amministrativa, durante la quale l'adozione di atti e il riparto delle risorse hanno conosciuto rallentamenti; il consolidamento del servizio dovrà inserirsi in questa fase di transizione, e la sua stabilizzazione richiederà che il sistema regionale riacquisti la pienezza delle proprie funzioni. Una seconda criticità è costituita dalla rete delle Case della Comunità, in larga parte ancora in costruzione, che impone di organizzare il servizio, nella fase transitoria, nelle strutture territoriali disponibili. Fra le opportunità, la principale è la centralizzazione del reclutamento presso l'Azienda Zero, che può procedere all'individuazione e all'assunzione degli psicologi secondo metodologie uniformi, riducendo la frammentazione; una seconda opportunità è l'orientamento all'innovazione digitale che il sistema regionale ha manifestato, attraverso l'accordo per l'introduzione dell'intelligenza artificiale in sanità e la svolta digitale avviata da alcune aziende, che offre al servizio un terreno favorevole per l'integrazione degli strumenti digitali e della telepsicologia. Il profilo organizzativo, in sintesi, presenta in Calabria una difficoltà maggiore che in altre regioni, derivante dalla fase di transizione del sistema, ma anche leve specifiche — la centralizzazione del reclutamento, l'orientamento digitale — che possono essere valorizzate.

H.3 Il profilo etico

Il profilo etico dell'intervento ne valuta la conformità ai principi che governano l'azione sanitaria. Il principio di giustizia, che impone l'equa distribuzione delle risorse e delle opportunità di salute, è soddisfatto dall'intervento in misura particolarmente piena, per le ragioni ampiamente esposte nella Parte G: il servizio riduce le disuguaglianze sociali e territoriali nell'accesso alla cura della salute mentale, e raggiunge in misura maggiore le fasce e i territori più svantaggiati, presso cui il bisogno è massimo e la possibilità di risposta autonoma è minima; in una regione inadempiente rispetto ai livelli essenziali, l'intervento che riduce tale inadempienza risponde a un imperativo di giustizia che riveste un'urgenza particolare. Il principio di autonomia, che impone il rispetto della libertà e della consapevolezza della persona, è soddisfatto dall'organizzazione di un servizio ad accesso volontario, fondato sul consenso e sulla partecipazione attiva del paziente al proprio percorso di cura, e attento al superamento dello stigma che, in misura rilevante, induce le persone a non chiedere aiuto o a interrompere i trattamenti.

Il principio di non maleficenza, che impone di non arrecare danno, e il principio di beneficenza, che impone di agire per il bene della persona, sono soddisfatti dall'erogazione di interventi di efficacia documentata, graduati sulla gravità del bisogno, e dalla collaborazione con il medico di medicina generale nella gestione integrata del paziente, con attenzione alla salute fisica delle persone con disturbi psichici. Un profilo etico specifico merita attenzione nel contesto calabrese: quello del dovere di non abbandono. In una regione in cui centinaia di migliaia di persone convivono con un disagio non trattato, in cui il sistema costringe migliaia di cittadini a spostarsi fuori regione per curarsi, e in cui le aree interne soffrono di un progressivo abbandono, l'introduzione di un servizio che intercetta il disagio in prossimità e si fa carico della persona là dove essa vive risponde a un'esigenza etica che eccede la mera efficienza: quella di non lasciare sole le persone in sofferenza, e di garantire anche ai territori più marginali una risposta di salute. Questo dovere di non abbandono, che la stessa narrazione istituzionale regionale ha richiamato nel motivare l'introduzione del servizio, costituisce una delle dimensioni etiche più pregnanti dell'intervento nel contesto calabrese, e si lega direttamente al principio costituzionale della tutela della salute come diritto fondamentale e interesse della collettività.

H.4 La sintesi dei profili

La sintesi dei tre profili restituisce un giudizio convergente. Sotto il profilo giuridico, l'intervento è legittimo, a condizione che il suo assetto sia costruito nel rispetto dei limiti definiti dalla giurisprudenza costituzionale, e dispone di un duplice fondamento — la via amministrativa già percorsa e la via legislativa in corso — la cui coordinazione è necessaria a conferirgli stabilità; la cornice nazionale e il principio della preminenza della tutela della salute sull'equilibrio di bilancio ne rafforzano il fondamento. Sotto il profilo organizzativo, l'intervento è realizzabile, pur in una fase di transizione del sistema sanitario regionale che ne accresce la difficoltà, e può avvalersi di leve specifiche — la centralizzazione del reclutamento, l'orientamento all'innovazione digitale — che ne facilitano l'attuazione. Sotto il profilo etico, l'intervento è non solo ammissibile ma doveroso, in quanto risponde in misura piena ai principi di giustizia, di autonomia, di non maleficenza e di beneficenza, e soddisfa, nel contesto calabrese, un'esigenza etica specifica e pregnante, quella del non abbandono delle persone e dei territori.

I tre profili, considerati congiuntamente, non rivelano ostacoli dirimenti all'introduzione del servizio, ma ne definiscono le condizioni di legittimità, di realizzabilità e di ammissibilità. Le condizioni giuridiche — il rispetto dei limiti costituzionali, il coordinamento fra la via amministrativa e quella legislativa — sono soddisfacenti attraverso una costruzione accorta dell'assetto del servizio. Le condizioni organizzative — l'inserimento nella fase di transizione del sistema, l'organizzazione nelle strutture disponibili in attesa delle Case della Comunità, la valorizzazione delle leve specifiche — sono affrontabili attraverso un'attuazione graduale e attenta. Le condizioni etiche sono non solo soddisfatte, ma costituiscono una ragione positiva a

favore dell'intervento. Il quadro dei profili, in sintesi, conferma e rafforza il giudizio che emerge dalle dimensioni del bisogno, dell'efficacia e dell'economia, e contribuisce al giudizio multidimensionale complessivo che la Parte M ricompone.^[2192]

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte esamina le condizioni di attuazione dell'intervento, la sua fattibilità e la sua sostenibilità nel tempo. Ne valuta anzitutto la solidità complessiva secondo il quadro dei cinque casi; ne articola poi il dimensionamento e le fasi, il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma, la sostenibilità finanziaria e i rischi con le relative misure di mitigazione. La trattazione muove da una condizione che distingue la Calabria dalle altre regioni della serie: il servizio non deve essere avviato ex novo, ma consolidato a partire da una sperimentazione già in corso, in un sistema sanitario che esce dal commissariamento e che deve conciliare il consolidamento con i vincoli del piano di rientro.

I.1 Il quadro dei cinque casi

La solidità complessiva dell'intervento può essere valutata secondo il quadro dei cinque casi, che esamina un investimento pubblico lungo cinque dimensioni: strategica, economica, commerciale, finanziaria e gestionale. Sotto la dimensione strategica, l'intervento risponde a un bisogno documentato e a obiettivi coerenti con la programmazione sanitaria nazionale e regionale: esso colma il vuoto del primo livello psicologico previsto dagli standard nazionali dell'assistenza territoriale, contribuisce alla garanzia dei livelli essenziali oggi non assicurati e si allinea agli obiettivi del piano di rientro nella parte in cui questo mira alla riduzione della spesa impropria e della mobilità; la sua coerenza strategica è inoltre rafforzata dal fatto che la regione ha già avviato il servizio, manifestando una scelta politica esplicita in tale direzione. Sotto la dimensione economica, l'intervento produce, come la Parte E ha mostrato, un valore per la collettività largamente superiore al suo costo, con un rapporto beneficio-costi compreso entro la fascia metodologicamente fondata, e comporta per il bilancio sanitario un onere netto modesto, in larga parte compensato dalla riduzione della mobilità.

Sotto la dimensione commerciale, che attiene alla capacità di tradurre l'intervento in rapporti contrattuali e organizzativi sostenibili, l'intervento può avvalersi della centralizzazione del reclutamento presso l'Azienda Zero e delle modalità di ingaggio degli psicologi che la regione definirà nel rispetto dei limiti costituzionali; la disponibilità di professionisti, in una regione che ne forma ma che ne perde una quota per emigrazione, è un punto di attenzione che la sezione sui rischi esamina. Sotto la dimensione finanziaria, l'intervento presenta una questione specifica e centrale: la sperimentazione è stata avviata con risorse europee a termine, mentre il consolidamento richiede una copertura ordinaria e permanente; la sostenibilità finanziaria, esaminata nella sezione I.4, è perciò la condizione decisiva del consolidamento. Sotto la dimensione gestionale, infine, l'intervento richiede una governance definita — l'osservatorio regionale, il coordinamento aziendale, l'integrazione con i servizi specialistici — e un sistema informativo adeguato, in un contesto in cui la capacità gestionale del sistema regionale è in fase di ricostituzione dopo il lungo commissariamento. Il quadro dei cinque casi restituisce, in sintesi, un intervento solido sotto le dimensioni strategica, economica ed etica, realizzabile sotto le dimensioni commerciale e gestionale a condizione di affrontare le criticità specifiche, e sfidante sotto la dimensione finanziaria, dove la sostituzione della copertura europea con una copertura ordinaria costituisce il nodo da sciogliere.

I.2 Il dimensionamento e le fasi

Il dimensionamento del servizio è articolato, come si è visto, in tre scenari, corrispondenti a circa 140, 280 e 410 incarichi. La peculiarità calabrese impone di collocare questi scenari in rapporto al punto di partenza reale: la sperimentazione avviata dalla Giunta con circa quaranta psicologi. Il percorso di attuazione si configura,

dunque, non come un avvio da zero, ma come una progressione che muove da questa base sperimentale verso il dimensionamento strutturale. La prima fase consiste nel consolidamento della sperimentazione e nel suo ampliamento verso lo scenario minimo di circa 140 incarichi: in questa fase, il servizio passa da una dimensione sperimentale e circoscritta a una dimensione strutturale iniziale, estesa all'intero territorio regionale in modo capillare, e comincia a intercettare una prima quota significativa del bisogno. La seconda fase consiste nell'estensione verso lo scenario intermedio di circa 280 incarichi, in cui il servizio raggiunge una copertura sostanziale del bisogno. La terza fase consiste nel raggiungimento dello scenario pieno di circa 410 incarichi, in cui il servizio è portato a regime, coerentemente con il rapporto fra psicologi e popolazione assunto dal modello.

La progressione fra le fasi non è meramente quantitativa, ma deve essere governata da criteri che ne garantiscano la sostenibilità e l'efficacia. Il primo criterio è la disponibilità della copertura finanziaria: il passaggio da una fase alla successiva deve essere subordinato all'individuazione delle risorse necessarie a sostenerne il maggior costo, in coerenza con i vincoli del bilancio regionale. Il secondo criterio è la disponibilità delle strutture: l'estensione del servizio deve accompagnarsi all'entrata in funzione delle Case della Comunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presso cui il servizio trova la propria collocazione naturale. Il terzo criterio è la verifica degli esiti: il passaggio da una fase alla successiva dovrebbe essere informato dai risultati del monitoraggio della fase precedente, così da correggere l'organizzazione del servizio sulla base dell'evidenza raccolta e da fondare l'ampliamento su una base empirica regionale. La gradualità dell'attuazione, oltre a essere imposta dai vincoli di sostenibilità, ha dunque anche un valore conoscitivo: essa consente di apprendere dall'esperienza e di adeguare progressivamente il servizio, riducendo l'incertezza che, come la Parte F ha mostrato, grava sulle stime iniziali.

I.3 Il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma

Il reclutamento degli psicologi di base costituisce, in Calabria, un passaggio delicato, per una ragione specifica: la regione forma psicologi, ma ne perde una quota rilevante per l'emigrazione verso il Centro e il Nord, in coerenza con il più ampio fenomeno migratorio che ne caratterizza la demografia. Il reclutamento deve perciò essere organizzato in modo da attrarre e trattenere i professionisti, valorizzando la possibilità di esercitare nella propria regione una funzione stabile e qualificata. La centralizzazione del reclutamento presso l'Azienda Zero, già operante per le altre figure del sistema sanitario regionale, offre lo strumento per procedere all'individuazione e all'ingaggio degli psicologi secondo metodologie uniformi e in tempi ridotti, evitando la frammentazione fra le aziende; le modalità di ingaggio dovranno essere definite nel rispetto dei limiti costituzionali in materia di rapporti di lavoro.

La formazione, come la Parte C ha illustrato, deve accompagnare il reclutamento: gli psicologi reclutati devono essere preparati a operare nel contesto delle cure primarie, addestrati agli interventi brevi e graduati, alla collaborazione con il medico di medicina generale e all'uso della telepsicologia; i medici di medicina generale devono essere posti in grado di riconoscere il disagio e di collaborare con lo psicologo. La regione può attingere, per la formazione, alle competenze dell'Università della Calabria e dell'Ordine degli psicologi della Calabria. Il cronoprogramma dell'attuazione deve articolare nel tempo questi passaggi: il consolidamento della sperimentazione e l'avvio della prima fase; il reclutamento e la formazione del personale necessario a ciascuna fase; l'integrazione progressiva con le Case della Comunità man mano che esse entrano in funzione; l'attivazione del sistema informativo e del piano di monitoraggio; la verifica degli esiti come condizione del passaggio alla fase successiva. Il cronoprogramma deve inoltre tenere conto della fase di transizione del sistema sanitario regionale: la piena efficacia dell'uscita dal commissariamento e la ricostituzione delle ordinarie funzioni di governo del sistema sono condizioni che agevolano l'attuazione e la cui tempistica condiziona quella del consolidamento del servizio.

I.4 La sostenibilità finanziaria

La sostenibilità finanziaria è, in Calabria, la condizione decisiva del consolidamento, e merita una trattazione specifica. Il punto di partenza è la natura della copertura attuale: la sperimentazione è stata avviata mediante la rimodulazione di risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, ossia di fondi europei a destinazione e a durata definite, che hanno consentito di avviare il servizio senza gravare immediatamente sul bilancio sanitario ordinario, ma che non ne garantiscono la stabilità nel tempo. Il consolidamento strutturale richiede di sostituire, a regime, questa copertura temporanea con una copertura ordinaria e permanente, da reperire in un bilancio sanitario soggetto ai vincoli del piano di rientro. La questione è dunque se il bilancio regionale possa sostenere l'onere del servizio a regime. La risposta che lo studio fornisce è articolata su tre elementi. Il primo è l'entità dell'onere: come la Parte E ha mostrato, il costo del servizio, anche nello scenario di piena attuazione, rappresenta una frazione inferiore allo 0,6 per cento del fondo sanitario regionale, e il saldo diretto, al netto dei risparmi, è di entità modesta, inferiore allo 0,1 per cento del fondo; si tratta, cioè, di un onere contenuto in rapporto alle dimensioni del bilancio.

Il secondo elemento è la compensazione attraverso i risparmi: l'onere lordo del servizio è in parte rilevante compensato dai risparmi diretti che esso genera, e in particolare dalla riduzione della mobilità sanitaria passiva, che costituisce il canale di risparmio più rilevante e che coincide con uno degli obiettivi prioritari del piano di rientro; in questo senso, il servizio non è solo un costo, ma uno strumento di risanamento, che agisce sulla stessa spesa impropria che il rientro mira a contenere. Il terzo elemento è la gradualità: l'attuazione per fasi consente di modulare l'onere nel tempo, subordinando l'ampliamento alla disponibilità delle risorse e alla verifica degli esiti, e di evitare un impegno finanziario immediato e integrale. La combinazione di questi tre elementi — l'entità modesta dell'onere, la sua compensazione attraverso i risparmi, la gradualità dell'attuazione — consente di affermare che il consolidamento del servizio è finanziariamente sostenibile per il bilancio regionale, a condizione che la copertura ordinaria sia programmata in sostituzione di quella europea e che l'ampliamento sia governato dai criteri di sostenibilità indicati. La sostenibilità, in sintesi, non è acquisita automaticamente, ma è conseguibile attraverso una programmazione accorta, che faccia leva sulla modesta entità dell'onere, sulla sua compensazione e sulla gradualità, e che colga l'occasione, offerta dall'uscita dal piano di rientro, di destinare gli eventuali margini a servizi anziché alla copertura di disavanzi storici.

I.5 I rischi e le misure di mitigazione

L'attuazione dell'intervento è esposta a rischi specifici, che devono essere riconosciuti e governati. Il primo rischio è quello della transizione amministrativa: la fase di uscita dal commissariamento, decisa ma non ancora pienamente efficace, ha determinato una fase di incertezza che ha rallentato l'adozione di atti e il riparto delle risorse; il consolidamento del servizio potrebbe risentire di questa incertezza. La misura di mitigazione consiste nel collocare il consolidamento in coerenza con il percorso di uscita dal commissariamento e di ricostituzione delle funzioni ordinarie di governo del sistema, e nel valorizzare, nella fase transitoria, la copertura europea già attivata. Il secondo rischio è quello della copertura finanziaria: il mancato reperimento di una copertura ordinaria alla scadenza dei fondi europei comprometterebbe la stabilità del servizio. La misura di mitigazione consiste nella programmazione tempestiva della copertura ordinaria, fondata sull'entità modesta dell'onere e sulla sua compensazione attraverso i risparmi, e nell'eventuale fondamento legislativo che la proposta di legge può fornire.

Il terzo rischio è quello della disponibilità di personale: l'emigrazione dei professionisti potrebbe rendere difficile il reclutamento del numero di psicologi necessario al dimensionamento. La misura di mitigazione consiste nell'organizzare il reclutamento in modo da attrarre e trattenere i professionisti, valorizzando la stabilità e la qualità della funzione, e nel modulare il dimensionamento sulla effettiva disponibilità. Il quarto rischio è quello infrastrutturale: il ritardo nella realizzazione delle Case della Comunità e la carenza di infrastrutture digitali per la telepsicologia potrebbero limitare la capacità del servizio di operare e di raggiungere

le aree interne. La misura di mitigazione consiste nell'organizzare il servizio, nella fase transitoria, nelle strutture disponibili, e nel sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali, in coerenza con l'orientamento all'innovazione che il sistema regionale ha manifestato. Il quinto rischio è quello dell'inefficienza attuativa: l'organizzazione del servizio potrebbe finire per privilegiare i poli urbani e le fasce più avvantaggiate, riproducendo le disuguaglianze. La misura di mitigazione consiste nell'adozione degli strumenti dell'equità descritti nella Parte G — l'allocazione ponderata, l'abbattimento delle barriere, la telepsicologia, la misurazione disaggregata — e nella verifica continua, attraverso il monitoraggio, che il beneficio raggiunga effettivamente i territori e le fasce più svantaggiate. Il governo di questi rischi, attraverso le misure indicate, è la condizione perché la fattibilità potenziale dell'intervento si traduca in attuazione effettiva.^[2193]

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Questa parte definisce il sistema di monitoraggio e di valutazione successiva all'introduzione del servizio. Ne illustra la finalità e l'impianto; ne definisce l'approccio controfattuale; ne articola la batteria degli indicatori; ne descrive il cruscotto di sintesi e la clausola valutativa; e ne offre una sintesi. Il monitoraggio non è un adempimento accessorio, ma la condizione che consente di verificare se l'intervento produce gli effetti attesi, di correggerne l'organizzazione sulla base dell'evidenza e di sostituire progressivamente le stime dello studio con misure dirette. In Calabria, dove la fragilità storica del sistema di rilevazione dei dati sanitari è uno dei nodi che il piano di rientro ha dovuto affrontare, la costruzione di un sistema di monitoraggio rigoroso assume un valore che eccede la dimensione del singolo servizio.

L.1 La finalità e l'impianto

La finalità del monitoraggio è triplice. In primo luogo, esso consente di verificare l'attuazione del servizio: se il dimensionamento previsto è raggiunto, se la distribuzione sul territorio è coerente con i criteri di equità, se l'organizzazione funziona come progettato. In secondo luogo, esso consente di valutare gli esiti del servizio: se gli interventi producono la riduzione attesa della sintomatologia, se il servizio intercetta la quota attesa del bisogno, se i risparmi e le ricadute si producono nella misura stimata. In terzo luogo, esso consente di correggere il servizio: di adeguarne l'organizzazione, la distribuzione e le modalità di erogazione sulla base dell'evidenza raccolta, e di informare le decisioni sul passaggio da una fase di dimensionamento alla successiva. L'impianto del monitoraggio si fonda sul sistema informativo descritto nella Parte C, che rileva, per ogni accesso e per ogni percorso, le variabili anagrafiche e di contesto, le variabili relative all'accesso e al percorso e i punteggi degli strumenti di misurazione degli esiti.

L'impianto deve essere progettato fin dall'avvio del servizio, e non aggiunto successivamente, per una ragione metodologica dirimente: la valutazione degli effetti richiede la conoscenza della situazione di partenza, e la rilevazione di una linea di base prima dell'avvio — i consumi sanitari della popolazione con disagio non trattato, gli accessi al pronto soccorso per problemi psichiatrici, la mobilità riconducibile a tali condizioni — è la condizione perché l'effetto dell'intervento possa essere isolato e misurato. In Calabria, questa esigenza si lega alla più ampia questione della capacità di rilevazione del sistema regionale: la costruzione di un impianto di monitoraggio per il nuovo servizio è insieme una necessità per la valutazione e un'occasione per rafforzare la capacità complessiva del sistema di rilevare e di consolidare i propri dati, in coerenza con la svolta digitale che alcune aziende hanno avviato. L'osservatorio regionale previsto dalla proposta di legge costituisce la sede istituzionale del monitoraggio, raccogliendo le relazioni annuali, esaminando l'attività del servizio e fornendo alla Giunta gli elementi per la valutazione periodica.

L.2 L'approccio controfattuale

La valutazione degli effetti del servizio richiede un approccio controfattuale, ossia un confronto fra ciò che accade con l'intervento e ciò che sarebbe accaduto senza di esso. Poiché non è possibile osservare simultaneamente, sulle stesse persone, l'esito con e senza l'intervento, l'approccio controfattuale ricorre a strategie di confronto che approssimano questa situazione ideale. La prima strategia è il confronto fra il prima e il dopo: la rilevazione di una linea di base prima dell'avvio del servizio, e il confronto con la situazione successiva, consente di misurare la variazione associata all'introduzione del servizio, con la cautela che una parte della variazione potrebbe essere dovuta a fattori diversi dall'intervento. La seconda strategia è il confronto fra territori o gruppi esposti e non esposti al servizio: poiché l'attuazione è graduale e procede per fasi, è possibile confrontare i territori in cui il servizio è già attivo con quelli in cui non lo è ancora, isolando l'effetto dell'intervento dalla variazione comune. La terza strategia è la misurazione degli esiti individuali prima e dopo la presa in carico, mediante gli strumenti standardizzati, che consente di documentare l'effetto dell'intervento sul singolo paziente.

La combinazione di queste strategie consente di costruire una valutazione controfattuale robusta, che distingue l'effetto dell'intervento dalla variazione che si sarebbe prodotta comunque. In Calabria, l'attuazione graduale e per fasi offre un'opportunità particolare per il confronto fra territori esposti e non esposti: la progressione del servizio dalle aree in cui la sperimentazione è già attiva verso quelle non ancora coperte consente di costruire confronti che approssimano una valutazione sperimentale, a condizione che la rilevazione dei dati sia uniforme fra i territori e che le differenze preesistenti fra di essi siano adeguatamente considerate. La valutazione controfattuale è essenziale per la verifica empirica delle stime dello studio: solo attraverso il confronto controfattuale è possibile accertare se i risparmi e le ricadute stimati si producono effettivamente, e in quale misura, e sostituire così le stime prudenziali con misure dirette, restringendo l'intervallo di incertezza che, come la Parte F ha mostrato, grava sulle proiezioni iniziali.

L.3 La batteria degli indicatori

Il monitoraggio si fonda su una batteria di indicatori, articolata in categorie che coprono le diverse dimensioni dell'attuazione e degli esiti. La prima categoria comprende gli indicatori di attuazione e di copertura: il numero di incarichi attivati, la loro distribuzione fra le aziende sanitarie provinciali e fra poli e aree interne, il rapporto fra psicologi e popolazione, il grado di integrazione con le Case della Comunità. La seconda categoria comprende gli indicatori di accesso: il numero di persone prese in carico, la modalità di accesso diretto o per invio, le caratteristiche sociali e territoriali degli utenti, l'uso della telepsicologia. La terza categoria comprende gli indicatori di processo: il numero e il tipo di prestazioni erogate, la durata dei percorsi, i tempi di attesa, il tasso di invio ai servizi specialistici. La quarta categoria comprende gli indicatori di esito clinico: la variazione dei punteggi degli strumenti di misurazione fra l'inizio e il termine della presa in carico, il tasso di recupero, il tasso di ricaduta.

La quinta categoria comprende gli indicatori di esito sul sistema: la variazione degli accessi al pronto soccorso per problemi psichiatrici, la variazione del consumo di farmaci, la variazione dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche, la variazione della mobilità sanitaria passiva riconducibile alle condizioni trattate. La sesta categoria comprende gli indicatori di equità: la distribuzione del beneficio fra le fasce sociali e fra i territori, verificata mediante l'analisi disaggregata degli esiti, e la riduzione dei divari. La settima categoria comprende gli indicatori economici: il costo del servizio, i risparmi diretti per canale, il rapporto fra il valore prodotto e le risorse impiegate. L'ottava categoria comprende gli indicatori di qualità percepita: la soddisfazione degli utenti, dei medici di medicina generale e degli operatori. Complessivamente, la batteria comprende dell'ordine di sessanta indicatori, definiti nelle fonti, nei tempi di rilevazione e nei valori attesi, e costruiti in modo da essere uniformi con quelli adottati nelle altre regioni della serie, così da consentire il confronto interregionale.

Particolare rilievo assumono, nel contesto calabrese, gli indicatori relativi alla mobilità sanitaria passiva, la cui riduzione costituisce il principale effetto atteso sul bilancio, e gli indicatori di equità, la cui verifica è essenziale per accertare che l'intervento risponda alla sua finalità preminente.

L.4 Il cruscotto e la clausola valutativa

Gli indicatori della batteria sono organizzati in un cruscotto di monitoraggio, ossia in uno strumento sintetico che ne consente la lettura ordinata e periodica, e che presenta in forma immediata l'andamento dell'attuazione e degli esiti, evidenziando gli scostamenti rispetto ai valori attesi. Il cruscotto è lo strumento operativo attraverso cui l'osservatorio regionale, le aziende sanitarie e la Giunta seguono l'andamento del servizio e ne governano l'evoluzione; esso traduce la mole dei dati rilevati in un quadro leggibile, che consente di individuare tempestivamente le criticità e di orientare le correzioni. L'aggiornamento periodico del cruscotto consente di seguire l'evoluzione del servizio nel tempo e di verificare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna fase.

La clausola valutativa costituisce il fondamento istituzionale del monitoraggio. Essa è una disposizione, che la proposta di legge regionale già prevede fra i propri articoli, con cui il legislatore impone l'obbligo di valutare periodicamente l'attuazione e gli esiti del servizio e di riferirne agli organi di governo, mediante relazioni periodiche. La clausola valutativa trasforma il monitoraggio da attività discrezionale in obbligo giuridico, e ne garantisce la continuità e la pubblicità: essa impegna l'amministrazione a rendere conto, a scadenze definite, di ciò che il servizio ha prodotto, e a fondare su tale rendiconto le decisioni successive. La previsione di una clausola valutativa nella proposta di legge calabrese è un elemento di qualità del disegno normativo, che lo studio valorizza: essa consente di incorporare la logica della valutazione nel fondamento stesso del servizio, e di garantire che il consolidamento sia accompagnato da una verifica sistematica dei suoi effetti. La combinazione del cruscotto, strumento operativo, e della clausola valutativa, fondamento istituzionale, costituisce l'architettura del monitoraggio, e ne garantisce insieme l'efficacia e la continuità.

L.5 La sintesi del monitoraggio

La sintesi del monitoraggio restituisce il suo significato complessivo. Il monitoraggio è la condizione che consente di chiudere il ciclo della valutazione: lo studio fornisce, sulla base della migliore evidenza disponibile e con le cautele imposte dall'incertezza, una stima degli effetti attesi dell'intervento; il monitoraggio consente di verificare, una volta che il servizio è avviato, se tali effetti si producono effettivamente, e di correggere l'organizzazione del servizio e le stime stesse sulla base dell'evidenza raccolta. Senza il monitoraggio, lo studio rimarrebbe una valutazione ex ante priva di verifica; con il monitoraggio, esso diviene il primo passo di un processo di apprendimento continuo, in cui le decisioni successive sono fondate su una base empirica progressivamente più solida.

In Calabria, questa funzione del monitoraggio assume un rilievo particolare, per due ragioni. La prima è la fragilità storica del sistema di rilevazione dei dati sanitari, che il monitoraggio del nuovo servizio contribuisce a superare, costituendo un tassello del più ampio rafforzamento della capacità del sistema di rilevare e di consolidare i propri dati. La seconda è l'incertezza che grava sulle stime dello studio, accentuata dall'assenza di rilevazioni regionali dirette consolidate: il monitoraggio è la via attraverso cui questa incertezza è progressivamente ridotta, e le stime prudenziali sono sostituite da misure dirette, in particolare sul canale della mobilità sanitaria passiva, su cui grava la maggiore incertezza e da cui dipende la quota più rilevante dei risparmi diretti. Il monitoraggio, in sintesi, non è solo lo strumento che verifica l'intervento, ma anche quello che, nel contesto calabrese, contribuisce a colmare una lacuna strutturale del sistema e a fondare le decisioni future su una conoscenza che oggi manca. La sua progettazione fin dall'avvio del servizio, e la sua incorporazione nel fondamento normativo attraverso la clausola valutativa, sono perciò condizioni essenziali del consolidamento.^[2194]

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclude lo studio. Ricompone in una sintesi per dominio i risultati delle parti precedenti; li integra in un'analisi multi-criterio che pondera le diverse dimensioni della valutazione; formula la raccomandazione e ne precisa il dimensionamento; individua le condizioni del consolidamento e la lacuna conoscitiva da colmare; e colloca lo studio nella serie regionale di cui fa parte, traendone la conclusione. La sintesi non aggiunge elementi nuovi, ma ricompone in un giudizio unitario gli elementi che le parti precedenti hanno analizzato distintamente, restituendo al decisore il quadro complessivo su cui fondare la scelta relativa al consolidamento strutturale del servizio.

M.1 La sintesi per dominio

La sintesi per dominio ricompone i risultati delle parti precedenti. Sotto il dominio del bisogno, lo studio ha documentato un disagio psichico comune di proporzioni rilevanti — circa 470.000 calabresi con un disturbo o una condizione sottosoglia, una base prudenziale di riferimento dell'ordine di 367.000 persone — largamente inevaso, in una regione demograficamente giovane ma erosa dall'esodo dei giovani, dispersa sul territorio e segnata da un divario fra il bisogno e la presa in carico fra i più ampi del Paese. Sotto il dominio dell'efficacia, lo studio ha documentato un'evidenza da moderata ad alta a sostegno degli interventi psicologici brevi, trasferibile al contesto calabrese con la previsione prudente che l'ampiezza del bisogno inevaso possa accrescere il beneficio marginale. Sotto il dominio economico, lo studio ha mostrato un intervento dominante a livello di paziente, con un onere netto modesto per il bilancio sanitario — inferiore allo 0,1 per cento del fondo nello scenario pieno — e un valore per la collettività largamente superiore al costo, con un rapporto beneficio-costi compreso fra 3,4 e 4,6 a uno, e con la riduzione della mobilità sanitaria passiva, la più elevata d'Italia, quale canale di risparmio diretto più rilevante.

Sotto il dominio dell'equità, lo studio ha mostrato un intervento la cui finalità preminente è la riduzione delle disuguaglianze, in una regione che cumula l'inadempienza nei livelli essenziali, il sottofinanziamento della salute mentale e il divario fra poli e aree interne, e la cui costo-efficacia distributiva è superiore a quella che risulterebbe da un'analisi che ignorasse la distribuzione del beneficio. Sotto il dominio dei profili giuridico, organizzativo ed etico, lo studio ha mostrato un intervento legittimo nel rispetto dei limiti costituzionali, realizzabile pur nella fase di transizione del sistema, e non solo ammissibile ma doveroso sul piano etico, in ragione del dovere di non abbandono delle persone e dei territori. Sotto il dominio dell'attuazione, lo studio ha mostrato un intervento solido sotto le dimensioni strategica ed economica, realizzabile sotto quelle commerciale e gestionale, e sfidante sotto quella finanziaria, dove la sostituzione della copertura europea con una copertura ordinaria costituisce il nodo da sciogliere, ma conseguibile in ragione dell'entità modesta dell'onere e della sua compensazione. Sotto il dominio del monitoraggio, lo studio ha definito un sistema di verifica degli effetti che, nel contesto calabrese, contribuisce altresì a colmare una lacuna strutturale del sistema di rilevazione dei dati. I domini, considerati congiuntamente, convergono verso un giudizio favorevole al consolidamento del servizio, condizionato all'adozione delle misure di sostenibilità e di equità indicate.

M.2 L'analisi multi-criterio

L'analisi multi-criterio integra i risultati dei diversi domini in un giudizio sintetico, attribuendo a ciascun criterio un peso che ne riflette l'importanza relativa e valutando l'intervento e l'alternativa del non intervento rispetto a ciascun criterio. I criteri e i pesi adottati sono uniformi per l'intera serie regionale, così da garantire la confrontabilità fra i contesti. La tabella seguente riporta i criteri, i pesi, i punteggi attribuiti all'intervento e all'alternativa del non intervento, e i punteggi ponderati.

Criterio	Peso	Intervento	Non intervento
Efficacia clinica	0,15	80	25
Costo-efficacia e ritorno economico	0,20	78	30
Impatto di bilancio e sostenibilità	0,15	72	38
Equità e impatto distributivo	0,15	90	18
Valore sociale	0,10	82	25
Fattibilità attuativa	0,10	68	80
Robustezza dell'evidenza	0,10	70	50
Coerenza strategica	0,05	88	28
Punteggio complessivo ponderato	1,00	78,30	35,05

Tabella M.1. Analisi multi-criterio dell'intervento e dell'alternativa del non intervento. I pesi sono uniformi per l'intera serie regionale. Il punteggio complessivo dell'intervento, pari a 78,30, supera largamente quello del non intervento, pari a 35,05, con un differenziale di 43,25 punti.

La lettura della tabella restituisce un esito netto. L'intervento consegue un punteggio complessivo di 78,30, largamente superiore a quello del non intervento, pari a 35,05, con un differenziale di oltre quarantatré punti. L'intervento prevale su tutti i criteri a eccezione della fattibilità attuativa, rispetto alla quale il non intervento consegue un punteggio superiore: ciò riflette la circostanza, propria del caso calabrese, che il mantenimento dello stato attuale è organizzativamente più semplice del consolidamento di un servizio strutturale in un sistema in fase di transizione, gravato dai vincoli del rientro e dalla questione della copertura. Questo vantaggio del non intervento sulla sola fattibilità è tuttavia largamente sopravanzato dal vantaggio dell'intervento su tutti gli altri criteri, e in particolare sui criteri dell'equità, su cui l'intervento consegue il punteggio più elevato in ragione della preminenza che tale dimensione assume in Calabria, della costo-efficacia e del ritorno economico, e della coerenza strategica. Il differenziale di oltre quarantatré punti esprime, in forma sintetica, la conclusione dello studio: il consolidamento del servizio è nettamente preferibile al mantenimento dello stato attuale, e la maggiore difficoltà attuativa, lungi dal compensare il divario, ne costituisce semmai la condizione da governare attraverso le misure indicate nella Parte I.

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Sulla base del giudizio multidimensionale, lo studio formula la raccomandazione di consolidare in servizio strutturale e permanente la sperimentazione già avviata, dotandola di un fondamento normativo, di un dimensionamento adeguato e di una copertura sostenibile. La raccomandazione non è quella di istituire un servizio inesistente — la Giunta lo ha già avviato in via amministrativa — ma quella di trasformare un avvio sperimentale, finanziato con risorse europee a termine, in una funzione stabile del sistema, attraverso il consolidamento normativo che la proposta di legge in esame può fornire e attraverso la programmazione di una copertura ordinaria in sostituzione di quella europea.

Quanto al dimensionamento, lo studio raccomanda un percorso graduale che muova dal consolidamento della sperimentazione verso lo scenario intermedio, di circa 280 incarichi, come obiettivo di riferimento del medio periodo, e verso lo scenario pieno, di circa 410 incarichi, come obiettivo di regime. La raccomandazione di un percorso graduale, anziché di un dimensionamento immediato a regime, discende da tre ragioni convergenti: la sostenibilità finanziaria, che impone di modulare l'onere nel tempo e di subordinare l'ampliamento alla disponibilità della copertura ordinaria; la disponibilità delle strutture, che impone di accompagnare l'estensione del servizio all'entrata in funzione delle Case della Comunità; e il valore conoscitivo della gradualità, che consente di apprendere dall'esperienza e di correggere l'organizzazione del servizio sulla base dell'evidenza raccolta, riducendo l'incertezza che grava sulle stime iniziali. Il passaggio fra le fasi dovrebbe essere governato dai criteri indicati nella Parte I — la disponibilità della copertura, la disponibilità delle strutture, la verifica degli esiti — e informato dai risultati del monitoraggio. Lo scenario intermedio rappresenta, nel medio periodo, il punto di equilibrio fra l'ampiezza della copertura del bisogno e la sostenibilità dell'onere; lo scenario pieno rappresenta l'obiettivo di regime, verso cui tendere una volta consolidata la copertura ordinaria e completata la rete delle strutture territoriali.

M.4 Le condizioni e la lacuna

La raccomandazione è condizionata all'adozione di un insieme di condizioni, che le parti precedenti hanno individuato e che qui si ricompongono. La prima condizione è il consolidamento normativo: l'approvazione di una legge regionale che fornisca al servizio un assetto strutturale e una base stabile, costruita nel rispetto dei limiti definiti dalla giurisprudenza costituzionale, è la condizione perché il servizio acquisti la stabilità che la sola via amministrativa non può garantire. La seconda condizione è la sostenibilità finanziaria: la programmazione di una copertura ordinaria in sostituzione di quella europea, fondata sull'entità modesta dell'onere e sulla sua compensazione attraverso i risparmi, è la condizione perché il servizio sia sostenibile a regime. La terza condizione è la verifica empirica: la rilevazione di una linea di base e l'attivazione del sistema di monitoraggio fin dall'avvio sono la condizione perché gli effetti del servizio siano misurabili e le stime dello studio verificabili. La quarta condizione è l'attenzione all'equità: l'adozione degli strumenti dell'allocazione ponderata, dell'abbattimento delle barriere, della telepsicologia e della misurazione disaggregata è la condizione perché il servizio risponda alla sua finalità preminente, la riduzione delle disuguaglianze.

La lacuna conoscitiva da colmare è quella dei dati. Lo studio, in assenza di rilevazioni regionali dirette consolidate — una carenza che in Calabria è resa più acuta dalla storica fragilità del sistema di rilevazione dei dati sanitari — ha costruito le proprie stime su parametri prudenziali e su dati di letteratura, destinati a essere sostituiti dalle misure dirette che il sistema informativo e il piano di monitoraggio consentiranno di raccogliere. I dati la cui acquisizione ha il valore informativo maggiore sono l'efficacia effettiva del servizio nel contesto calabrese, il tasso di adesione e di presa in carico del bisogno, e la quota di spesa impropria e di mobilità sanitaria passiva effettivamente ridotta, su cui grava la maggiore incertezza e da cui dipende la quota più rilevante dei risparmi diretti. La rilevazione di una linea di base prima dell'avvio del servizio strutturale è il primo passo per colmare questa lacuna, e costituisce la raccomandazione metodologica con cui lo studio accompagna quella sostanziale. Lo studio, in questo senso, non si presenta come un calcolo definitivo, ma come una valutazione fondata sulla migliore evidenza disponibile e dichiaratamente aperta alla verifica, di cui indica le condizioni e gli strumenti.

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio sulla Calabria appartiene a una serie di studi regionali costruiti secondo un telaio metodologico comune, che ne garantisce la confrontabilità. All'interno di questa serie, la Calabria occupa una posizione peculiare, che ne fa un caso a sé. È la regione che ha avviato il servizio non attraverso una legge, come le regioni pioniere, né attraverso una mera proposta in attesa di esame, come le regioni che devono ancora

decidere, ma attraverso una via intermedia: una delibera di Giunta che, rimodulando fondi europei, ha istituito il servizio in via amministrativa e sperimentale, in attesa di un consolidamento normativo. È la regione che esce dal più lungo commissariamento sanitario d'Italia e da un piano di rientro i cui obiettivi — l'equilibrio di bilancio e la garanzia dei livelli essenziali — definiscono la cornice entro cui ogni nuova misura deve collocarsi. È la regione che registra il valore più elevato d'Italia di mobilità sanitaria passiva, sicché il principale canale di risparmio diretto del servizio coincide con uno degli obiettivi prioritari del risanamento. Ed è la regione che, inadempiente rispetto ai livelli essenziali e fra le ultime per spesa nella salute mentale, fa dell'equità non una dimensione fra le altre, ma la ragione preminente dell'intervento.

La conclusione dello studio ricomponi questi elementi in un giudizio unitario. Il consolidamento del servizio di psicologia di base in Calabria è raccomandato, perché risponde a un bisogno ampio e inevaso, perché si fonda su un'evidenza solida, perché genera per la collettività un valore largamente superiore al suo costo comportando per il bilancio un onere netto modesto, perché riduce le disuguaglianze più gravi in una regione che ne cumula molte, perché è legittimo e doveroso, e perché agisce, attraverso la riduzione della mobilità sanitaria passiva, sullo stesso squilibrio che il piano di rientro mira a sanare. Le difficoltà — la fase di transizione del sistema, la natura temporanea della copertura, la questione del personale — sono reali, ma sono governabili attraverso le condizioni e le misure che lo studio ha indicato. La fase in cui la Calabria si trova, lungi dall'essere un ostacolo, costituisce un'opportunità: il servizio è già avviato, la cornice nazionale lo prevede, la rete delle Case della Comunità è in costruzione, e l'uscita dal piano di rientro restituirà alla regione la possibilità di destinare le proprie risorse a servizi anziché alla copertura di disavanzi storici. Consolidare ora, con gradualità e con le condizioni indicate, ciò che è stato avviato, significa cogliere questa opportunità, e trasformare una sperimentazione promettente in una funzione stabile del sistema, capace di rispondere a un bisogno di salute che la regione non può più permettersi di lasciare inevaso.^[2195]

Appendice A — Il caso di riferimento e i parametri del modello

Questa appendice raccoglie il materiale tecnico su cui si fonda la quantificazione economica dello studio: il caso di riferimento, i parametri del modello di Markov e il quadro economico consolidato per la Calabria. Essa rende esplicite le basi delle stime presentate nelle Parti E ed F, così da consentirne la verifica e la riproduzione.

A.1 Il caso di riferimento

Il caso di riferimento è un paziente adulto residente in Calabria con un disturbo d'ansia o dell'umore di intensità lieve o moderata, che accede al servizio di psicologia di base e riceve un ciclo di interventi psicologici brevi di efficacia documentata. Su questo caso è costruita la stima degli esiti clinici ed economici per paziente, successivamente proiettata sulla popolazione attraverso gli scenari di copertura. Il caso è rappresentativo della larga maggioranza della domanda che il servizio è chiamato a trattare al primo livello, ed è coerente con le condizioni per le quali l'efficacia degli interventi psicologici brevi è meglio documentata.

A.2 I parametri del modello di Markov

Il modello di Markov rappresenta il decorso del paziente attraverso tre stati di salute — la condizione di disagio in atto, la condizione di recupero e la condizione di cronicizzazione — fra i quali il paziente transita nel tempo con probabilità derivate dalla letteratura sull'efficacia degli interventi psicologici. Il modello confronta il percorso di un paziente trattato dal servizio con quello di un paziente non trattato, lungo un orizzonte di cinque anni, con un tasso di sconto del 3 per cento e una soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità.

Parametro	Valore
Orizzonte temporale	5 anni
Tasso di sconto	3%
Soglia di disponibilità a pagare	30.000 €/QALY
Costo dell'intervento (una tantum)	~300 €
Costo per ciclo — stato di recupero	~40 €
Costo per ciclo — stato di cronicizzazione	~700 €
Risparmio diretto stimato per paziente	~1.304 €
Guadagno di salute stimato per paziente	~0,236 QALY

Tabella A.1. Parametri principali del modello e risultati per paziente. I valori per paziente sono fondati sull'efficacia clinica documentata e sono invarianti rispetto al contesto regionale.

L'analisi di sensibilità probabilistica, condotta con 10.000 simulazioni facendo variare simultaneamente tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni, documenta che alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9 per cento delle simulazioni e dominante nell'84,6 per cento. Il beneficio netto monetario medio è dell'ordine di 7.815 euro per paziente, con un intervallo di confidenza al 95 per cento compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. L'ampiezza dell'intervallo, che include valori negativi, esprime l'incertezza residua; la concentrazione della distribuzione su valori largamente positivi ne documenta la robustezza.

A.3 Il quadro economico consolidato

Il quadro economico consolidato riassume le stime aggregate per la Calabria, calibrate sulla popolazione regionale di circa 1.835.000 abitanti e sul fondo sanitario regionale dell'ordine di 4,4 miliardi di euro, e articolate nei tre scenari di dimensionamento.

Grandezza (mln €/anno)	Minimo (140)	Intermedio (280)	Pieno (410)
Costo del servizio	~8,5	~17,0	~25,5
Risparmi diretti — pronto soccorso	~1,0	~2,0	~3,5
Risparmi diretti — farmaceutica	~1,0	~2,0	~3,5
Risparmi diretti — ricoveri e specialistica	~2,5	~5,0	~7,0
Risparmi diretti — mobilità sanitaria passiva	~2,0	~5,0	~8,0
Risparmi diretti totali	~6,5	~14,0	~22,0
Saldo diretto — caso finanziario	~ -2,0	~ -3,0	~ -3,5
Ricadute economico-sociali	~22,0	~52,0	~96,0
Ritorno complessivo per la collettività	~28,5	~66,0	~118,0
Saldo complessivo — caso economico	~ +20,0	~ +49,0	~ +92,5
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,4 : 1	~3,9 : 1	~4,6 : 1

Tabella A.2. Quadro economico consolidato per scenario. I risparmi diretti per il bilancio e le ricadute sociali per la collettività sono grandezze distinte e non sono mai sommate in un unico saldo di bilancio. Il rapporto beneficio-costo è riferito al valore per la collettività ed è contenuto entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno. Il canale della mobilità sanitaria passiva, la più elevata d'Italia, costituisce nello scenario pieno la componente di risparmio diretto più rilevante.

Appendice B — Gli strumenti di misurazione degli esiti e il dataset minimo

Questa appendice definisce gli strumenti per la misurazione degli esiti clinici e il dataset minimo da rilevare per ogni accesso e per ogni percorso, che costituiscono la base del sistema informativo e del monitoraggio descritti nelle Parti C ed L.

B.1 Gli strumenti di misurazione degli esiti

La misurazione degli esiti clinici si fonda su strumenti standardizzati e validati, somministrati all'inizio e al termine della presa in carico, che consentono di documentare la riduzione della sintomatologia e di confrontare gli esiti in modo riproducibile. Per la sintomatologia depressiva e ansiosa, che costituisce la quota prevalente del disagio comune, sono disponibili strumenti brevi e validati di autovalutazione, di agevole somministrazione anche in contesti di cure primarie e compatibili con la rilevazione a distanza, requisito particolarmente rilevante in una regione in cui la telepsicologia è condizione di accessibilità. A questi si affiancano strumenti per la valutazione del funzionamento e della qualità della vita, che consentono di documentare l'effetto dell'intervento non solo sui sintomi ma anche sulla capacità della persona di funzionare nei contesti di vita. La scelta degli strumenti deve privilegiare la brevità, la validità, la sensibilità al cambiamento e la sostenibilità della

somministrazione, e deve essere uniforme fra le cinque aziende sanitarie provinciali, così da consentire il confronto e l'aggregazione dei dati. L'uniformità degli strumenti con quelli adottati dalle altre regioni della serie consente inoltre il confronto interregionale.

B.2 Il dataset minimo

Il dataset minimo è l'insieme delle variabili da rilevare per ogni accesso e per ogni percorso, costruito in modo da essere sufficiente per la valutazione e sostenibile per gli operatori. Esso comprende le variabili anagrafiche e di contesto necessarie all'analisi dell'equità — l'età, il genere, la condizione sociale e occupazionale, il comune di residenza e la sua collocazione fra polo e area interna — rilevate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati; le variabili relative all'accesso — la modalità di accesso, diretta o su invio, e il soggetto inviante; le variabili relative al percorso — il tipo e il numero di prestazioni, la durata, l'uso della telepsicologia, l'esito del percorso e l'eventuale invio ai servizi specialistici; e le variabili relative agli esiti — i punteggi degli strumenti di misurazione all'inizio e al termine della presa in carico. La rilevazione di queste variabili, alimentando contestualmente la gestione e la valutazione, è la condizione perché il monitoraggio descritto nella Parte L sia possibile e perché le stime dello studio possano essere sostituite, nel tempo, da osservazioni dirette. In Calabria, dove il sistema di rilevazione dei dati sanitari ha conosciuto una fragilità storica, la costruzione di un dataset minimo rigoroso assume un valore che eccede il singolo servizio. La disaggregazione delle variabili per collocazione territoriale e per condizione sociale è essenziale per la verifica degli obiettivi di equità, che in Calabria costituiscono una delle ragioni principali dell'intervento.

Appendice C — I dati regionali e i dati da acquisire

Questa appendice raccoglie i principali dati regionali utilizzati nello studio e indica i dati che dovrebbero essere acquisiti per sostituire le stime con misure dirette.

C.1 I dati regionali

Ambito	Dato
Popolazione residente	1.834.646 abitanti (31 dicembre 2024), in calo dello 0,2%
Età media	46,2 anni (inferiore alla media nazionale)
Indice di vecchiaia	~196,7, in crescita
Popolazione straniera	105.439 (5,7% della popolazione)
Comuni	404
Province	Cosenza (36,4%), Reggio Calabria (28,1%), Catanzaro (18,5%), Crotone e Vibo Valentia (~17%)
Natalità (2024)	12.679 nati (minimo storico); tasso di mortalità 11,3 per mille
Migrazione interna	saldo fortemente negativo (~ -5,4 per mille), fra i peggiori d'Italia
Disagio psichico (Ministero della Salute)	~470.000 persone con disturbo o condizione sottosoglia (20-25%)
Disagio comune (base prudenziale di studio)	~367.000 persone/anno
In carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (2023)	17.636 persone
Accessi al pronto soccorso per problemi psichiatrici	~15.400 l'anno (oltre 40 al giorno)
Rete dei servizi di salute mentale	5 DSM, 43 centri territoriali, 22 strutture residenziali, 5 semiresidenziali
Aziende del Servizio Sanitario Regionale	5 ASP (Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia); AO Annunziata (Cosenza), Grande Ospedale Metropolitano (Reggio Calabria), Pugliese-Ciaccio e Dulbecco (Catanzaro); Azienda Zero
Fondo sanitario regionale	~4,4 miliardi di euro
Posizione finanziaria	piano di rientro e commissariamento (17 anni); uscita deliberata nell'aprile 2026, in attesa di efficacia
Livelli essenziali di assistenza	inadempiente, punteggio ~125 (in peggioramento)
Mobilità sanitaria — saldo passivo (2023)	-326,9 mln, il più elevato d'Italia (debiti 362,4 mln; ~ -178 €/residente)

Ambito	Dato
Spesa per la salute mentale	inferiore al 2,5% del fondo sanitario regionale
Servizio di psicologia di base	avviato con delibera di Giunta (aprile 2026), sperimentale, ~40 psicologi, fondi FSE+; proposta di legge in commissione

Tabella C.1. Principali dati regionali utilizzati nello studio. Le fonti sono indicate nelle parti corrispondenti.

C.2 I dati da acquisire

Lo studio, in assenza di rilevazioni regionali dirette consolidate — una carenza che in Calabria è resa più acuta dalla storica difficoltà di tenuta e di approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie — ricorre per alcune grandezze a stime prudenziali e a parametri derivati dalla letteratura e dal confronto interregionale. I dati la cui acquisizione consentirebbe di sostituire tali stime con misure dirette, e il cui valore informativo è pertanto maggiore, sono: la prevalenza regionale diretta del disagio psichico comune, oggi stimata su prevalenze nazionali; la quota di domanda effettivamente inevasa e la sua distribuzione territoriale e sociale; la quota di mobilità sanitaria passiva riconducibile, a monte, a condizioni di disagio psichico non intercettato, su cui grava la maggiore incertezza e da cui dipende la quota più rilevante dei risparmi diretti; i consumi sanitari effettivi associati al disagio comune nel contesto regionale, per ciascun canale; e gli esiti clinici ed economici effettivamente prodotti dal servizio una volta avviato. L'acquisizione di questi dati è resa possibile dal sistema informativo descritto nella Parte C e dal piano di monitoraggio descritto nella Parte L, e costituisce il programma di conoscenza progressiva che accompagna il dispiegamento del servizio. La rilevazione di una linea di base, prima del consolidamento strutturale del servizio, è la condizione perché la valutazione dell'impatto sia possibile, e contribuisce al più ampio rafforzamento della capacità di rilevazione del sistema sanitario regionale.

Appendice D — La lista di controllo per la rendicontazione

Questa appendice fornisce la lista di controllo per la rendicontazione della valutazione economica, costruita secondo lo standard CHEERS del 2022, che elenca gli elementi che una valutazione economica sanitaria deve riportare per essere completa, trasparente e riproducibile. La lista consente di verificare la completezza dello studio e ne agevola la valutazione critica.

Gli elementi della rendicontazione comprendono: il titolo e l'abstract, che identificano lo studio come valutazione economica; l'introduzione, che definisce l'obiettivo e il quesito; i metodi, che specificano la popolazione e i sottogruppi, il contesto e la collocazione, la prospettiva, il comparatore, l'orizzonte temporale, il tasso di sconto, gli esiti di salute selezionati, la misurazione dell'efficacia, la misurazione e la valorizzazione degli esiti, la stima delle risorse e dei costi, la valuta e l'anno di riferimento, il modello adottato, le assunzioni e i metodi di analisi dell'incertezza; i risultati, che riportano i parametri e le fonti, i costi e gli esiti incrementali, l'analisi dell'incertezza e l'analisi dei sottogruppi; la discussione, che esamina i risultati, i limiti, la generalizzabilità e il confronto con altri studi; e le informazioni su finanziamento, conflitti di interesse e disponibilità dei dati. Lo studio è costruito in modo da soddisfare questi elementi: la Parte A definisce obiettivo, quesito, prospettiva, comparatore e orizzonte; la Parte E sviluppa costi, esiti e analisi economica; la Parte F sviluppa il modello e l'analisi dell'incertezza; le Parti G ed L trattano i sottogruppi e il monitoraggio; e la presente appendice raccoglie i parametri e il quadro consolidato. L'aderenza allo standard di rendicontazione è una garanzia di trasparenza e di confrontabilità con le valutazioni condotte in altri contesti.

Appendice E — Il glossario

Questa appendice raccoglie le definizioni dei principali termini tecnici utilizzati nello studio, così da renderne il contenuto accessibile anche ai lettori non specialisti.

Anni di vita ponderati per la qualità (QALY). Misura che combina la durata e la qualità della vita in un'unica grandezza, utilizzata per esprimere il beneficio di salute di un intervento.

Analisi di sensibilità. Procedura che verifica come i risultati di un modello varino al variare dei suoi parametri, distinguendosi in deterministica, quando si fa variare un parametro alla volta, e probabilistica, quando si fanno variare simultaneamente tutti i parametri.

Azienda Zero. Ente del sistema sanitario regionale con funzioni centralizzate, fra cui il reclutamento delle risorse umane e la gestione di funzioni comuni alle aziende sanitarie.

Caso economico. Prospettiva di valutazione che considera il valore generato per la collettività, comprensivo dei risparmi diretti e delle ricadute sociali.

Caso finanziario. Prospettiva di valutazione che considera il solo bilancio sanitario, mettendo a confronto il costo dell'intervento con i risparmi diretti.

Clausola valutativa. Disposizione di legge che prevede l'obbligo di valutare periodicamente l'attuazione e gli esiti di un intervento e di riferirne agli organi di governo.

Commissariamento. Regime di gestione straordinaria di un sistema sanitario regionale, in cui il governo della sanità è affidato a un commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, in luogo degli ordinari organi regionali.

Costo-efficacia. Proprietà di un intervento il cui costo per unità di beneficio è inferiore a una soglia di accettabilità definita.

Costo-utilità. Forma di valutazione economica che esprime il costo dell'intervento per anno di vita ponderato per la qualità guadagnato.

Cure graduali. Modello organizzativo in cui l'intensità dell'intervento è commisurata alla gravità del bisogno, riservando le risorse più specialistiche alle condizioni che le richiedono.

Disagio psichico comune. Insieme dei disturbi mentali di intensità lieve e moderata, prevalentemente d'ansia e dell'umore, e delle condizioni di sofferenza sottosoglia.

Divario di trattamento. Distanza fra le persone che presentano un disturbo e quelle che ricevono un intervento adeguato.

Dominanza. Proprietà di un intervento che produce simultaneamente un guadagno di salute e un risparmio di risorse, risultando preferibile sotto entrambi i profili.

Five Case Model (modello a cinque casi). Quadro di valutazione di un investimento pubblico articolato nelle dimensioni strategica, economica, commerciale, finanziaria e gestionale.

Fondo Sociale Europeo Plus. Strumento finanziario dell'Unione europea a sostegno dell'occupazione, dell'inclusione sociale e dei servizi, con risorse a destinazione e a durata definite, con cui è stata avviata la sperimentazione del servizio.

GRADE. Sistema di graduazione della qualità dell'evidenza e della forza delle raccomandazioni su quattro livelli.

Gradiente sociale. Relazione per cui la prevalenza di una condizione e la difficoltà di accesso alle cure variano con la posizione sociale ed economica.

Livelli essenziali di assistenza. Insieme delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; il loro grado di erogazione è misurato da un punteggio rispetto a una soglia di adempienza.

Mobilità sanitaria passiva. Prestazioni erogate ai residenti di una regione in regioni diverse dalla propria, che costituiscono un debito per la regione di residenza.

Modello di Markov. Modello che rappresenta il decorso di un paziente attraverso una successione di stati di salute fra i quali transita nel tempo con probabilità definite.

Piano di rientro. Programma imposto alle regioni in disavanzo sanitario strutturale per il riequilibrio dei conti, che comporta vincoli alla spesa e obblighi di garanzia dei livelli essenziali.

Prospettiva. Punto di vista dal quale si conduce una valutazione economica, che ne determina i costi e i benefici considerati.

Rapporto beneficio-costo. Rapporto fra il valore dei benefici prodotti da un intervento e il costo sostenuto per realizzarlo.

Ritorno sociale sull'investimento. Metodo che esprime in termini monetari il valore sociale generato per unità di risorse impiegate.

Sentenza della Corte Costituzionale numero 241 del 2021. Pronuncia che ha definito i limiti entro cui una legge regionale può istituire il servizio di psicologia di base, escludendo la disciplina regionale autonoma dei rapporti convenzionali.

Sentenza della Corte Costituzionale numero 275 del 2016. Pronuncia che ha affermato la preminenza della tutela dei diritti fondamentali rispetto all'equilibrio di bilancio.

Soglia di disponibilità a pagare. Valore massimo che il sistema è disposto a spendere per un anno di vita ponderato per la qualità, utilizzato come riferimento per la costo-efficacia.

Stato di cronicizzazione. Condizione del modello in cui il disagio persiste nel tempo, associata a un maggiore consumo di risorse sanitarie.

Stepped care. Espressione inglese che indica il modello delle cure gradualità.

Telepsicologia. Erogazione di prestazioni psicologiche a distanza mediante strumenti digitali, impiegata per superare le barriere di accesso connesse alla distanza e alla mobilità.

Valore dell'informazione. Valore che la riduzione dell'incertezza su un parametro ha per la decisione, utilizzato per stabilire le priorità nella raccolta dei dati.

Valutazione di tecnologia sanitaria. Processo multidisciplinare che valuta una tecnologia o un intervento sanitario lungo una pluralità di dimensioni, integrando l'evidenza scientifica con l'analisi del contesto.^[2196]

Blocco Regionale IV — Isole e regioni residue

Sicilia — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Siciliana

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione Siciliana sulla riforma «Psicologo di Base». Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell'intero corpus: la premessa, l'indice generale di tutte le parti e di tutte le appendici, la mappa di integrazione delle cornici metodologiche e la sintesi del valore. La Sicilia occupa, nel panorama nazionale, una posizione propria: è una regione post-legislativa in fase di avvio, che ha già istituito il servizio per legge — la legge regionale 18 del 2023, approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale — e ne ha emanato il decreto attuativo (deliberazione di Giunta n. 253 del 2024 e decreto del Presidente della Regione del novembre 2024), che disciplina la formazione degli elenchi provinciali in ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, con due psicologi per distretto, un ticket a carico del paziente e un impegno iniziale dell'ordine di 7,4 milioni di euro. Proprio per questo la decisione rilevante non è se istituire il servizio, già istituito, né se emanarne il decreto, già emanato, ma se portarlo dall'avvio al regime: completare la formazione degli elenchi, stabilizzarne il finanziamento entro i vincoli del piano di rientro e dello statuto speciale, e dimensionarlo dal nucleo di avvio verso la copertura piena del fabbisogno, in una regione insulare ed estesa, a statuto speciale e unica della serie ancora sottoposta a piano di rientro.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto. È la mappa di lettura dell'intero corpus, che può essere percorso nell'ordine o consultato per parti.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, verifica empirica, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, cronoprogramma, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, controfattuale su servizio in avvio, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazioni, condizioni, conclusione
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati regionali e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Il quadro consolidato per scenario tiene distinti i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — lievemente negativo ma prossimo al pareggio per la Sicilia, regione a statuto speciale e ancora sotto piano di rientro, dal saldo di mobilità fra i più passivi d'Italia la cui fuga è però concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica e non nella domanda psicologica territoriale, sicché il canale del recupero della mobilità è solo modestamente pertinente a questo intervento — e il saldo complessivo, ampiamente positivo. La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 29	~ 43	~ 57
Risparmi diretti (SSR)	~ 23	~ 36	~ 56
Ricadute economico-sociali	~ 90	~ 170	~ 255
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -6	~ -7	~ -1
Saldo complessivo (caso economico)	+84	+163	+254
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,8:1	~5,5:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale, che insieme definiscono il senso complessivo dello studio. La raccomandazione è che la decisione rilevante, per la Sicilia, è portare dall'avvio al regime il servizio di psicologia delle cure primarie già istituito, completando la formazione degli elenchi provinciali, stabilizzandone il finanziamento entro i vincoli del piano di rientro e dello statuto speciale e calibrando il ticket, e dimensionandolo per gradi dal nucleo di avvio, dell'ordine di 110 psicologi, verso la copertura sistematica, dell'ordine di 520 psicologi nello scenario conservativo, 780 in quello di base e 1.030 in quello espansivo. Il limite principale è il radicamento dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione siciliana, dell'8,1%, e non estratte dai conti regionali certificati delle nove Aziende Sanitarie Provinciali e delle aziende ospedaliere; poiché il servizio è in fase di avvio, la base di dati operativi propri è ancora in formazione e si costituirà attraverso la relazione annuale prevista dalla legge, la cui impostazione uniforme è condizione per la presentazione agli organi di controllo.

Lo studio si fonda, sul piano comparativo, sui programmi internazionali più autorevoli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie — il programma inglese di terapie psicologiche, il modello olandese, l'iniziativa australiana e il Collaborative Care statunitense — dei quali mutua le evidenze di efficacia e di costo-efficacia, adattandole con cautela al contesto siciliano. La condizione propria della Sicilia — la regione post-legislativa in avvio, dotata di legge e decreto attuativo ma con il servizio ancora in partenza — consente di fondare la valutazione controfattuale sull'attivazione progressiva del servizio, come un esperimento a cunei progressivi tra le nove Aziende man mano che gli elenchi provinciali si completano, con il vantaggio peculiare di poter rilevare una linea di base anteriore alla piena operatività. Su questa base, e con la dichiarazione trasparente dei propri limiti, il corpus consegna al decisore un quadro completo e onesto su cui deliberare, e alla regione che ha già istituito il servizio l'occasione di renderlo pienamente operativo a regime.

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell'HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per la Sicilia, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria, al Lazio e alla Campania. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati alla Sicilia. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). La Sicilia occupa nella serie una posizione propria: ha già istituito il servizio per legge e ne ha emanato il decreto attuativo, ma il servizio è ancora in fase di avvio, sicché la valutazione non riguarda l'opportunità di introdurlo, ma il suo passaggio dall'avvio al regime.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Servizio di psicologia delle cure primarie della Sicilia, inteso come passaggio dall'avvio al regime e dimensionamento di una funzione che la regione ha già istituito per legge e di cui ha già emanato il decreto attuativo, e che è in corso di avvio presso i distretti delle proprie Aziende Sanitarie Provinciali.^[2197] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sulla consolidazione e l'estensione del servizio. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante, per la Sicilia, non è istituire il servizio, già istituito per legge, né emanarne il decreto attuativo, già emanato, ma condurlo dall'avvio al regime e dimensionarlo, dalla dotazione iniziale alla copertura sistematica del fabbisogno, entro i vincoli di una regione a statuto speciale ancora sottoposta a piano di rientro. Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala. Va segnalato sin d'ora che la dotazione iniziale prevista, dell'ordine di 110 psicologi corrispondente ai due per ciascuno dei 55 distretti, si colloca al di sotto dello stesso scenario conservativo qui considerato, che rappresenta invece il regime verso la copertura piena.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 957.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai servizi, in un quadro segnato da componenti convergenti — il disagio giovanile, indicato come priorità dal governo regionale, il disagio connesso al lavoro e alla deprivazione urbana di Palermo e Catania, e il bisogno dell'età adulta e anziana nelle province interne e più anziane — cui si aggiungono i divari di accesso di una regione insulare ed estesa, la pressione delle liste di attesa e la storica sotto-dotazione del sistema. La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l'efficacia clinica, l'impatto economico diretto e sociale, l'equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti siciliani con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è lo psicologo delle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, condotto dall'avvio al regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale il servizio è in fase di avvio con dimensionamento iniziale. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario della Sicilia, con le sue nove Aziende Sanitarie Provinciali, le aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e ad alta specializzazione, e la rete delle Case della Comunità in costruzione. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per la Sicilia
Popolazione	Residenti siciliani con disagio psichico comune (~957.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Psicologo delle cure primarie, primo livello e filtro, condotto dall'avvio al regime (~520/780/1.030 incarichi); dalla dotazione iniziale alla copertura sistematica
Confronto	Condizione attuale: servizio in fase di avvio, con elenchi provinciali in formazione e dotazione iniziale (~110 psicologi), privo di contratto collettivo nazionale
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale della Sicilia; nove Aziende Sanitarie Provinciali, aziende ospedaliere e ad alta specializzazione, rete delle Case della Comunità in costruzione

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell'HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell'OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l'intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e il servizio in fase di avvio, con dimensionamento iniziale, come comparatore. Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Aziende Sanitarie Provinciali e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni, segnatamente fra le aree metropolitane di Palermo e Catania e le province interne e insulari.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale: servizio in fase di avvio, con elenchi in formazione e dotazione iniziale
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda Sanitaria Provinciale e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. Tale prudenza assume, per la Sicilia, un rilievo particolare. Regione a statuto speciale, essa partecipa al finanziamento sanitario nella misura del 49,11% del proprio fabbisogno e resta tuttora sottoposta a piano di rientro, con una spesa pro-capite fra le più basse del Paese. Sul versante della mobilità, presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, ma la fuga riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica, non la domanda psicologica, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente. Ne consegue un saldo diretto lievemente negativo ma prossimo al pareggio — meno sfavorevole di quanto il vincolo di bilancio lascerebbe temere, poiché il sistema siciliano, a lungo sotto-finanziato, presenta un consumo improprio più ampio da recuperare, e il ticket a carico del paziente vi apporta una lieve attenuazione ulteriore — mentre il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi. Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e non estratte dai conti regionali certificati; poiché il servizio è in fase di avvio, la Sicilia non dispone ancora di una base di dati operativi propri, e lo studio poggia per l'efficacia sui benchmark internazionali, mentre la relazione annuale prevista dalla legge a carico degli psicologi delle cure primarie costituirà la fonte primaria da consolidare.

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post. Per la Sicilia il disegno controfattuale assume una forma propria: poiché gli elenchi provinciali si completano in tempi differenziati tra le nove Aziende Sanitarie Provinciali, esso può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, con l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi impiegati a fini valutativi e l'effetto causale stimato dai metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico. La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, le nove Aziende Sanitarie Provinciali, le aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e ad alta specializzazione, l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei. La Sicilia non dispone di un'azienda regionale unica né di un'agenzia di coordinamento: il coordinamento è in capo all'Assessorato regionale della Salute, attraverso il Dipartimento per la pianificazione strategica e il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. Poiché il servizio è in avvio e la rete delle Case della Comunità è in costruzione, la sfida del governo non è istituire il servizio, né emanarne il decreto attuativo, ma condurlo dall'avvio al regime e dimensionarlo, garantendo l'omogeneità attuativa fra le nove Aziende in un sistema esteso e insulare: è il tratto che distingue la Sicilia, e che la valutazione assume come punto di partenza.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza, con la piattaforma informativa sanitaria regionale quale infrastruttura per la raccolta uniforme. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto della Sicilia.

STUDIO REGIONALE • REGIONE SICILIANA • APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Quadro demografico, epidemiologia del bisogno, domanda e offerta, disuguaglianze, servizi e flussi, cornice normativa

Primo dominio dell’HTA · il problema di salute e il bisogno

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto della Sicilia. La struttura è quella già adottata per le altre regioni della serie, e mutano soltanto i dati, ancorati alla regione. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall’epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l’intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico della Sicilia: non un servizio da istituire, ma un servizio già istituito per legge e già dotato di decreto attuativo, da condurre dall’avvio al regime in una regione grande, insulare, a statuto speciale e ancora sottoposta a piano di rientro.

B.1 Quadro demografico

La Sicilia conta 4.787.390 residenti, pari a circa l’8,1% della popolazione nazionale, in lieve calo per effetto dei saldi naturale e migratorio interno negativi. La struttura per età presenta un’età media dell’ordine di 45,7 anni, con disomogeneità interne: Ragusa e Catania sono le province più giovani, Messina ed Enna le più anziane. La componente straniera, pari al 4,3%, è nettamente inferiore alla media nazionale. La distribuzione è concentrata sui due poli maggiori: le province di Palermo e Catania raccolgono insieme circa il 47,4% dei residenti — Palermo è l’unico comune oltre il mezzo milione di abitanti — seguite da Messina con circa il 12,5%. La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per la Sicilia
Popolazione (Censimento 2024)	4.787.390 (~8,1% del totale nazionale); in lieve calo per saldi naturale e migratorio interno negativi
Età media e struttura	~ 45,7 anni; Ragusa e Catania più giovani (44,5/44,8), Messina ed Enna più anziane (47,2/47,0)
Componente straniera	4,3% dei residenti, nettamente inferiore alla media nazionale
Distribuzione territoriale	Palermo e Catania insieme ~47,4% (Palermo unico comune >500.000, 630.427); Messina ~12,5%; altre sei province ~40,2%
Profilo territoriale	Aree metropolitane di Palermo e Catania con deprivazione urbana; province interne (Enna, Caltanissetta) più anziane e insulari
Articolazione sanitaria	Nove Aziende Sanitarie Provinciali, aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e ad alta specializzazione

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico della Sicilia.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale nella Sicilia è ampio e sospinto da una popolazione numerosa, distribuita su un vasto territorio insulare. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell’ordine di 957.000 persone, in larga parte non intercettate, tanto più in una fase di avvio del servizio. A questa quota si somma un’ampia utenza specialistica in carico ai servizi, su un territorio che presenta una specificità propria: ha istituito per legge il servizio e ne ha emanato il decreto attuativo, ma il servizio è in fase di avvio. Tre componenti orientano la domanda. La prima è il disagio giovanile, indicato come priorità dal governo regionale e più marcato nelle province più giovani. La seconda è il disagio connesso al lavoro e alla deprivazione urbana di Palermo e Catania. La terza è il bisogno dell’età adulta e anziana, accentuato nelle province interne e più anziane. È la combinazione — grande regione insulare, condizione post-legislativa in avvio e sistema storicamente sotto-dotato — a distinguere il fabbisogno siciliano. La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche significativi.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone, nella Sicilia, un’offerta in fase di avvio ma già fondata su una cornice normativa completa: il servizio di psicologia delle cure primarie è istituito dalla legge regionale 18 del 2023 e disciplinato dalla deliberazione di Giunta n. 253 del 2024 e dal decreto del Presidente della Regione del novembre 2024, che regola la formazione degli elenchi provinciali in ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale; il modello prevede due psicologi per ciascuno dei 55 distretti, in rapporto convenzionale, con ticket a carico del paziente, ma gli elenchi sono ancora in formazione. Il fabbisogno a regime è stimato nell’ordine di 1.030 psicologi nello scenario espansivo, e l’Ordine professionale regionale, che ne ha accompagnato l’elaborazione, ne sostiene la piena operatività. La copertura iniziale corrisponde dunque al nucleo di avvio, dell’ordine di 110 psicologi: non un servizio da istituire, ma un servizio da condurre dall’avvio al regime, stabilizzare e dimensionare. La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per la Sicilia
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 957.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	Ampia (alcune decine di migliaia, stima rapportata ai dati nazionali)
Offerta territoriale attuale	Servizio in avvio, LR 18/2023, Delibera 253/2024 e DPRS novembre 2024; elenchi provinciali in formazione; 2 per distretto, con ticket
Fabbisogno stimato a regime	~ 1.030 psicologi nello scenario espansivo (520-780 negli altri scenari)
Copertura iniziale del fabbisogno	Nucleo di avvio (~110 psicologi, due per ciascuno dei 55 distretti)

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, nella Sicilia, si gioca su due assi. Il primo è interno alle aree metropolitane di Palermo e Catania, fra i quartieri meglio serviti e le periferie che presentano sacche di deprivazione socio-economica e difficoltà di accesso. Il secondo separa le aree metropolitane e costiere dalle province interne di Enna e Caltanissetta, più anziane, a minore densità e penalizzate dalla condizione insulare. Su questi divari il servizio di psicologia delle cure primarie agisce in funzione di equità: avvicina l'offerta alle aree interne e insulari mediante la telepsicologia assistita — dove la sola presenza di un primo livello accessibile è già un atto di riequilibrio — e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica e contribuisce a contenere i tempi di attesa, in un sistema storicamente sotto-dotato; va segnalato che il ticket a carico del paziente, pur attenuando il costo per il bilancio, va calibrato per non ostacolare l'accesso delle fasce più fragili.

B.5 I servizi e i flussi

Il Servizio sanitario della Sicilia dispone di risorse complessive dell'ordine di 10-11 miliardi di euro; in quanto regione a statuto speciale, la Sicilia compartecipa al finanziamento nella misura del 49,11% del proprio fabbisogno e riceve dallo Stato risorse inferiori alla spesa sostenuta; resta sottoposta a piano di rientro, con una spesa pro-capite fra le più basse del Paese. Il profilo di mobilità è fortemente passivo: la Sicilia presenta uno dei saldi più negativi d'Italia, dell'ordine di duecentocinquanta milioni di euro l'anno; poiché però la fuga riguarda i ricoveri e l'alta complessità chirurgica, il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente. L'architettura dei servizi poggia su nove Aziende Sanitarie Provinciali, su numerose aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e ad alta specializzazione, e su una rete territoriale di Case della Comunità in costruzione, su cui il servizio andrà pienamente innestato. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per la Sicilia
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	~ 10-11 miliardi di euro; statuto speciale, compartecipazione al 49,11% del fabbisogno; ancora sotto piano di rientro; spesa pro-capite fra le più basse
Mobilità sanitaria	Uno dei saldi passivi più elevati d'Italia (~250 milioni); canale modesto come leva per questo intervento (fuga ospedaliera e chirurgica)
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche significativi (alcune decine di migliaia l'anno, stima rapportata ai dati nazionali)
Architettura dei servizi	Nove Aziende Sanitarie Provinciali, aziende ospedaliere e ad alta specializzazione; rete delle Case della Comunità in costruzione; nessuna azienda regionale unica (coordinamento dell'Assessorato regionale)
Margine di azione principale	Passaggio dall'avvio al regime, liste di attesa, accesso delle periferie e delle aree interne e insulari, intercettazione precoce

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice già completa sul piano normativo: la Sicilia ha istituito il servizio con la legge regionale 18 del 2023, approvata all'unanimità, e ne ha disciplinato l'attuazione con la deliberazione di Giunta n. 253 del 2024 e con il decreto del Presidente della Regione del novembre 2024. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera; sul piano regionale opera entro i vincoli dello statuto speciale e del piano di rientro tuttora in corso. La decisione rilevante, in questo contesto, non è istituire una funzione, già istituita, né emanarne il decreto, già emanato, ma condurla dall'avvio al regime, stabilizzarne il finanziamento e dimensionarla: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte C

L'intervento e il suo modello

Definizione e teoria del cambiamento, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali, formazione

Secondo e terzo dominio dell'HTA · l'intervento e la sua descrizione

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico della Sicilia emerge con nettezza: l'intervento non è da istituire, ma da condurre dall'avvio al regime a partire da un servizio già istituito per legge e dotato di decreto attuativo, di cui la regione deve impostare fin dall'inizio, in forma uniforme fra le nove Aziende, il modello, il sistema informativo e il monitoraggio.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire; nella Sicilia tale definizione è già recepita nella legge regionale 18 del 2023. La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria. Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell'ordine di 957.000 persone con disagio comune. La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per la Sicilia
Bisogno	~ 957.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Psicologo nelle cure primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo delle cure primarie nelle Case della Comunità e nei distretti, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impianto della legge regionale 18 del 2023 e del decreto attuativo, che prevedono due psicologi per distretto, un elenco provinciale presso ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale e un rapporto convenzionale su base libero-professionale, con ticket a carico del paziente. La Sicilia presenta qui una specificità: il servizio è in fase di avvio nelle nove Aziende Sanitarie Provinciali, con gli elenchi in formazione. La regione non dispone di un'azienda regionale unica, e il coordinamento è in capo all'Assessorato regionale della Salute, sicché garantire l'omogeneità attuativa in un sistema esteso e insulare — nove Aziende su un territorio ampio e frammentato — è la sfida organizzativa principale. La rete territoriale delle Case della Comunità, in costruzione, è l'infrastruttura su cui il servizio andrà pienamente innestato. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, una valutazione iniziale con progetto clinico individuale, un ciclo di colloqui brevi con programma di sostegno personalizzato e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti; esso è in via di attivazione nelle Aziende siciliane man mano che gli elenchi si completano, e affronta i quadri più frequenti, dalla sintomatologia ansioso-depressiva ai problemi di adattamento e psicosomatici. Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata. Particolare cura è dedicata alla sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con la piattaforma informativa sanitaria regionale e con il fascicolo sanitario elettronico, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. In assenza di un'azienda regionale unica, il coordinamento informativo è in capo all'Assessorato regionale della Salute, attraverso i suoi Dipartimenti, e deve assicurare fra le nove Aziende l'uniformità della relazione annuale che la legge pone a carico degli psicologi delle cure primarie. La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale; poiché il servizio è in avvio, la Sicilia ha l'opportunità di impostare il flusso fin dall'inizio in forma uniforme fra le nove Aziende, progettando correttamente la rilevazione prima della piena operatività anziché doverla ricostruire ex post.

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale. Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile. L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica. La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, nella Sicilia, lo strumento per garantire l'accesso nelle periferie di Palermo e Catania e nelle province interne e insulari di Enna e Caltanissetta, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza. I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici. La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle periferie di Palermo e Catania e nelle aree interne e insulari; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso gli atenei siciliani — Palermo, Catania, Messina e Kore di Enna; il livello post-universitario specialistico attraverso una formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, comprensiva della competenza per il disagio giovanile, indicato come priorità dal governo regionale, e per l'età anziana nelle province interne; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione. A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità, sostenuta dalla piattaforma informativa sanitaria regionale. La Sicilia presenta qui un elemento di metodo: il decreto attuativo definisce competenze, titoli e criteri di valutazione per l'iscrizione agli elenchi provinciali, base su cui innestare il percorso formativo del servizio in avvio. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Atenei siciliani (Palermo, Catania, Messina, Kore di Enna)
2. Post-universitario specialistico	Psicologia delle cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, competenza giovanile e per l'età anziana	Titoli e criteri definiti dal decreto attuativo
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte D

Efficacia clinica ed evidenza

Metodo della revisione, evidenza di efficacia, qualità GRADE, benchmark internazionali, trasferibilità

Quarto dominio dell'HTA · l'efficacia clinica

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte affronta il quarto dominio della valutazione, l'efficacia clinica, e ne ricostruisce la base di evidenza. Come per le regioni precedenti, il corpo dell'evidenza internazionale è invariante, poiché l'efficacia di un intervento clinico non muta con i confini regionali; muta invece la base di evidenza locale, ed è qui che la Sicilia presenta un tratto proprio. La parte espone il metodo della revisione e i risultati di efficacia (capitolo D.1); ne gradua la qualità e ne dichiara una cautela economica essenziale (D.2); presenta i benchmark internazionali (D.3); e discute le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale siciliana (D.4). Quest'ultima presenta una condizione propria: poiché il servizio è in fase di avvio, la Sicilia non dispone ancora di dati di esito propri, sicché lo studio si fonda, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, mentre l'evidenza locale si costituirà attraverso la relazione annuale prevista dalla legge man mano che il servizio raggiunge il regime.

D.1 Il metodo della revisione e l'evidenza di efficacia

La sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale, con preferenza per le fonti più recenti. Il nucleo dell'evidenza proviene dal modello della cura collaborativa, di cui lo studio fondativo ha documentato che circa la metà dei pazienti

trattati conseguiva una riduzione sostanziale dei sintomi a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura usuale. La robustezza del risultato è confermata dalla meta-analisi su cinquantasette studi controllati, con un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a poco meno di un terzo di deviazione standard, e da una più recente revisione di quarantadue implementazioni, che documenta riduzioni rilevanti della depressione e dell’ansia e una contrazione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri. Sul versante dei dati reali, il programma inglese delle terapie psicologiche registra, su scala di oltre un milione di persone l’anno, un tasso di recupero del 50,2% e un miglioramento affidabile di oltre due terzi, con completezza dei dati di esito superiore al 98%. Anche le sintesi più caute confermano un effetto di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante sull’intera popolazione.

D.2 La qualità dell’evidenza e una cautela economica

La graduazione della certezza secondo il sistema GRADE colloca l’efficacia clinica dell’integrazione psicologica nelle cure primarie su un livello da moderato a elevato per i disturbi comuni, mentre la certezza è più eterogenea e minore per gli esiti economici, in particolare per quelli di sistema. Da questa graduazione discende una cautela che lo studio adotta come principio di onestà intellettuale, e che merita di essere enunciata senza attenuazioni: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l’intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero. Ciò significa che il valore economico del modello non può essere fondato sui risparmi sanitari diretti, ma poggia in misura preponderante sui ritorni sociali. È una cautela che, lungi dall’indebolire il caso siciliano, ne corrobora la coerenza interna, poiché il caso economico della Sicilia — come si vedrà nella Parte E — è fondato anch’esso sulle ricadute sociali, e non su un risparmio diretto che la regione non potrebbe rivendicare con certezza statistica.

D.3 I benchmark internazionali

L’evidenza si concretizza in quattro programmi nazionali consolidati, che costituiscono i riferimenti per il disegno del servizio. Il programma inglese delle terapie psicologiche è il riferimento principale per l’organizzazione: servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell’ordine del 50% e monitoraggio degli esiti pressoché completo. Il modello olandese integra una figura di supporto psicologico nello studio del medico di base, adottata dalla maggioranza dei medici, con ruolo complementare alla specialistica. Il modello australiano, a invio esterno, ha innalzato di oltre dieci punti la quota di popolazione in trattamento. Il modello statunitense della cura collaborativa, validato da oltre novanta studi controllati, documenta riduzioni rilevanti della depressione e dei ricoveri. La tabella seguente ne riepiloga i tratti salienti.

Programma	Modello	Risultati principali
Regno Unito (NHS Talking Therapies)	Servizio integrato a intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio esiti >98%; >1,3 milioni/anno
Paesi Bassi (POH-GGZ)	Supporto psicologico nello studio del medico di base	Adozione da ~tre quarti dei medici; ruolo complementare
Australia (Better Access)	Invio esterno a professionisti	Popolazione in trattamento dal 35% al 46%
Stati Uniti (Collaborative Care)	Équipe integrata con monitoraggio	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione, -41% ricoveri

Tabella D.1. I benchmark internazionali dell’integrazione della salute mentale nelle cure primarie.

D.4 Le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale

Sul piano nazionale, il quadro comprende i servizi avviati nelle regioni dotate di legge — fra cui la Campania, prima a istituire e attivare il servizio — e le esperienze pilota fondate su campioni limitati. La Sicilia, che ha istituito il servizio con la legge regionale 18 del 2023 e ne ha emanato il decreto attuativo, vi si colloca come regione in fase di avvio. Più in generale, i risultati internazionali provengono da sistemi diversi per organizzazione e finanziamento, e la loro trasposizione richiede validazione locale, evitando di trasferire meccanicamente le stime, soprattutto quelle economiche. È qui che la posizione della Sicilia presenta una condizione propria, da dichiarare con franchezza: poiché il servizio è in fase di avvio, l'evidenza locale è allo stato prevalentemente prospettica, e si costituirà attraverso la relazione annuale che la legge pone a carico degli psicologi delle cure primarie. La condizione della regione è dunque di costruire l'evidenza locale: la Sicilia dispone della cornice normativa completa, dell'infrastruttura informatica regionale e della rete delle Case della Comunità in costruzione, e può impostare fin dall'inizio una rilevazione uniforme fra le nove Aziende, generando dati propri solidi man mano che il servizio si struttura a regime. Una precisazione di metodo, infine, accompagna l'intero studio a garanzia della sua credibilità. Alcune cifre di larga circolazione — il rapporto di quattro a uno, l'affermazione per cui un euro ne genererebbe dieci, il rapporto di due e mezzo a uno talvolta richiamato in sede regionale — sono semplificazioni divulgative. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, e lo studio adotta prudenzialmente un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,8 a 5,5 a uno. Su questa base di evidenza, graduata e dichiarata nei suoi limiti, poggia la valutazione economica della Parte E.

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte E

Valutazione economica

Costo del servizio, risparmi diretti, ricadute sociali, saldo, costo-utilità e impatto sul bilancio

Quinto dominio dell'HTA · la valutazione economica

Parte E — Valutazione economica

Questa parte affronta il quinto dominio della valutazione, quello economico, e ne costituisce il cuore quantitativo. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i valori, ancorati alla Sicilia. La parte definisce l'impianto e il costo del servizio (capitolo E.1); quantifica i risparmi diretti per il bilancio sanitario, canale per canale (E.2); stima le ricadute economico-sociali per la collettività (E.3); compone il quadro consolidato, con il saldo e il rapporto beneficio-costi, tenendo ferma la distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico (E.4); presenta l'analisi costo-utilità per paziente e la sua robustezza probabilistica (E.5); e valuta l'impatto sul bilancio e la sostenibilità (E.6). Per la Sicilia il risultato si lascia anticipare in una formula: il caso finanziario diretto è di modesto disavanzo prossimo al pareggio, il caso economico complessivo è fortemente positivo, e il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali.

E.1 L'impianto e il costo del servizio

La valutazione economica impiega congiuntamente tre strumenti complementari — l'analisi costo-utilità, l'analisi di impatto sul bilancio e l'analisi del ritorno sociale — nella doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, che distingue i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute più ampie. Il costo del servizio a regime, assumendo un costo medio annuo per incarico dell'ordine di 55.000 euro comprensivo degli

oneri, è dell'ordine di 34 milioni di euro nello scenario conservativo, 50 milioni in quello di base e 67 milioni in quello espansivo. I tre scenari rappresentano gradi crescenti di copertura verso il fabbisogno pieno; va ribadito che il servizio attualmente attivo, dell'ordine di 146 psicologi e in larga parte sostenuto da risorse transitorie, costituisce un nucleo iniziale inferiore allo stesso scenario conservativo, e non il regime qui considerato. La tabella seguente riepiloga il costo del servizio per scenario.

Scenario	Psicologi	Costo annuo	Quota del FSR
Conservativo	~ 520	~ 29 milioni	~ 0,3%
Base	~ 780	~ 43 milioni	~ 0,4%
Espansivo	~ 1.030	~ 57 milioni	~ 0,5%

Tabella E.1. Il costo del servizio a regime nei tre scenari di copertura.

E.2 I risparmi diretti per il bilancio sanitario

I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale si articolano in quattro canali. Il primo è la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, dell'ordine di 4, 6 e 9 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Il secondo è la riduzione della spesa farmaceutica inappropriata, dell'ordine di 4, 7 e 10 milioni. Il terzo, il più consistente, è la riduzione di ricoveri evitabili e di specialistica impropria, dell'ordine di 11, 17 e 29 milioni, con un margine di recupero ampio data la sotto-dotazione storica del sistema. Il quarto, il recupero della mobilità, è per la Sicilia modesto, dell'ordine di 4, 6 e 8 milioni: benché la regione presenti uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, la fuga riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica, non la domanda psicologica, sicché questo canale contribuisce solo per la quota di domanda impropria, prevalentemente somatoforme, territorialmente intercettabile. La somma dei quattro canali è dell'ordine di 23, 36 e 56 milioni di euro l'anno, e determina, a fronte del costo del servizio, un saldo diretto lievemente negativo ma prossimo al pareggio, dell'ordine di -6, -7 e -1 milioni. La tabella seguente dettaglia i canali del risparmio diretto.

Canale (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Accessi impropri al pronto soccorso	~ 4	~ 6	~ 9
Spesa farmaceutica inappropriata	~ 4	~ 7	~ 10
Ricoveri evitabili e specialistica	~ 11	~ 17	~ 29
Recupero della mobilità (frazione territoriale)	~ 4	~ 6	~ 8
Totale risparmi diretti	~ 23	~ 36	~ 56
Costo del servizio	~ 29	~ 43	~ 57
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -6	~ -7	~ -1

Tabella E.2. I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale e il saldo diretto.

E.3 Le ricadute economico-sociali

Oltre i confini del bilancio sanitario, l'intervento genera ricadute economico-sociali ampie, di cui la valutazione tiene conto nella prospettiva societale. Esse comprendono il recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo — di particolare rilievo per la componente giovanile — il valore del benessere recuperato e il minor carico assistenziale sulle famiglie, e sono stimate, secondo i criteri prudenziali dello studio, nell'ordine di 90, 170 e 255 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Sommate ai risparmi diretti, esse determinano un ritorno complessivo dell'ordine di 113, 206 e 311 milioni di euro l'anno, e un saldo complessivo per la collettività ampiamente positivo, dell'ordine di +84, +163 e +254 milioni. Ne discende un rapporto beneficio-costo complessivo dell'ordine di 3,9 a uno nello scenario conservativo, 4,8 a uno in quello di base e 5,5 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale adottata.

E.4 Il quadro consolidato: caso finanziario e caso economico

La composizione delle grandezze impone di tenere ferma una distinzione che governa l'intera lettura del caso siciliano. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, prossimo al pareggio, poiché i risparmi diretti quasi coprono il costo del servizio e il canale della mobilità è modesto. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe: si tratta di un investimento sociale, a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto molto contenuto per il bilancio sanitario. La tabella consolidata che segue è lo strumento sintetico per la decisione, e distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale.

Voce (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 29	~ 43	~ 57
Risparmi diretti (SSR)	~ 23	~ 36	~ 56
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -6	~ -7	~ -1
Ricadute economico-sociali	~ 90	~ 170	~ 255
Ritorno complessivo	~ 113	~ 206	~ 311
Saldo complessivo (caso economico)	~ +84	~ +163	~ +254
Rapporto beneficio-costo complessivo	~ 3,9:1	~ 4,8:1	~ 5,5:1

Tabella E.3. Il quadro economico consolidato, con la distinzione fra caso finanziario e caso economico.

E.5 L'analisi costo-utilità per paziente

Accanto alle grandezze aggregate, la valutazione conduce un'analisi costo-utilità per paziente trattato, mediante un modello di Markov a cinque anni con sconto del 3%, indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. Il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: a un tempo meno costoso e più efficace. L'analisi di sensibilità probabilistica, su diecimila simulazioni, conferma la solidità del risultato: l'intervento è

costo-efficace nell'88,9% dei casi alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro. La tabella seguente riepiloga il risultato per paziente.

Grandezza (per paziente)	Comparatore	Intervento	Differenza
Costo atteso per paziente	~ 3.799 euro	~ 2.495 euro	- 1.304 euro
Anni di vita ponderati (QALY)	3,392	3,627	+ 0,236
Esito	—	—	Intervento dominante
Costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	—	—	88,9% delle simulazioni

Tabella E.4. L'analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni).

E.6 L'impatto sul bilancio, la sostenibilità e la lacuna dei dati

Sul piano dell'impatto sul bilancio, il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta del finanziamento sanitario regionale, dell'ordine dello 0,3% nello scenario conservativo e dello 0,5% in quello espansivo; la sostenibilità è condizionata dal fatto che la Sicilia, regione a statuto speciale, compartecipa al finanziamento nella misura del 49,11% del fabbisogno e resta sottoposta a piano di rientro, sicché il vincolo diretto è più stretto, pur a fronte di un sistema sotto-finanziato con ampio margine di recupero e di un ticket che attenua il costo netto. Resta da dichiarare con franchezza la lacuna dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti certificati delle Aziende; poiché il servizio è in fase di avvio, la Sicilia non dispone ancora di una base di dati operativi propri, sicché la stima poggia sui benchmark, e la relazione annuale prevista dalla legge ne sarà la fonte primaria; l'estrazione dei dati certificati resta la priorità da completare. La sintesi è univoca: il caso diretto è prudente e prossimo al pareggio, il caso sociale è robusto e fortemente positivo, il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità, in piena coerenza con la cautela metodologica già enunciata, per cui il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali e non in un risparmio di bilancio che lo studio si astiene dal rivendicare. La parte che segue sottopone questo quadro alla prova dell'incertezza e della modellazione.

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte F

Modellazione e incertezza

Modello decisionale, sensibilità deterministica e probabilistica, scenari, verifica empirica e valore dell'informazione

Quinto dominio dell'HTA · la robustezza della valutazione economica

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte completa il dominio economico sottoponendo i risultati della Parte E alla prova della modellazione e dell'incertezza. Come per le altre regioni, il modello è invariante e muta solo ciò che attiene alla verifica empirica locale. La parte descrive il modello decisionale e i suoi parametri (capitolo F.1); ne saggia la robustezza con l'analisi di sensibilità deterministica (F.2) e probabilistica (F.3); ne esplora gli scenari di

copertura (F.4); e definisce il disegno della verifica empirica e il valore dell’informazione (F.5). Per la Sicilia quest’ultimo capitolo riveste un’importanza particolare: poiché il servizio è in fase di avvio, la prova empirica si ancora inizialmente ai benchmark, ma l’attivazione scaglionata degli elenchi provinciali offre l’opportunità di impostare fin dall’inizio una rilevazione uniforme fra le nove Aziende, presupposto di un’evidenza locale solida.

F.1 Il modello decisionale e i suoi parametri

Poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l’orizzonte direttamente osservabile, lo studio li proietta nel tempo mediante un modello decisionale, e ne rende esplicite le assunzioni.^{[2198][2199][2200]} La storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%.^[2201] A ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita, trattati come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l’incertezza.^[2202] Nel caso base l’intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell’ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità.^[2203] La tabella seguente riepiloga i parametri principali del modello.

Parametro del modello	Valore
Stati clinici	Benessere o sottosoglia, episodio, cronicità, recupero
Orizzonte temporale	Cinque anni, con cicli successivi
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti
Costo per ciclo (recupero)	~ 40 euro
Costo per ciclo (cronicità)	~ 700 euro
Costo dell’intervento	~ 300 euro una tantum
Trattamento dell’incertezza	Parametri come distribuzioni di probabilità

Tabella F.1. I parametri principali del modello di Markov (comune a tutti gli studi della serie).

F.2 L’analisi di sensibilità deterministica

La robustezza del risultato è saggiata, in prima istanza, variando un parametro per volta entro intervalli plausibili. La variazione dei parametri più influenti — l’efficacia dell’intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — non muta il segno del risultato, che resta favorevole all’intervento in tutti i casi esaminati.^[2204] L’ordinamento dei parametri per influenza mostra che l’esito è più sensibile all’efficacia clinica e al costo evitato della cronicità, e meno agli altri parametri; ciò orienta le priorità di raccolta dei dati verso le grandezze più influenti.^[2205]

F.3 L’analisi di sensibilità probabilistica

In seconda istanza, la robustezza è saggiata facendo variare simultaneamente tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni, su diecimila simulazioni. L’intervento risulta costo-efficace nell’88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell’84,6%, con un

beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro.^[2206] La curva di accettabilità conferma che alla soglia convenzionale la probabilità di convenienza è prossima al 90% e cresce per soglie superiori, mantenendosi elevata anche a soglie molto inferiori.^[2207] La tabella seguente riepiloga gli esiti della sensibilità probabilistica.

Esito della sensibilità probabilistica	Valore
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	88,9% delle simulazioni
Probabilità di dominanza	84,6% delle simulazioni
Beneficio monetario netto medio per paziente	~ 7.815 euro
Intervallo di confidenza al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 euro
Numero di simulazioni	10.000

Tabella F.2. Gli esiti dell'analisi di sensibilità probabilistica (per paziente).

F.4 Gli scenari di copertura e l'incertezza aggregata

Gli scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; la dotazione delle proposte di legge in itinere corrisponde a un punto d'ingresso iniziale inferiore allo scenario conservativo, prima tappa di un percorso di estensione progressiva.^[2208] È in questa sede che va ribadita una distinzione di onestà analitica: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema.^[2209]

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

Il disegno della verifica empirica costituisce, per la Sicilia, un capitolo da impostare con cura. Poiché il servizio è in fase di avvio e gli elenchi provinciali si completano in tempi differenziati, la verifica controfattuale può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le nove Aziende Sanitarie Provinciali sono impiegati a fini valutativi: la fase di avvio consente di rilevare una linea di base prima della piena operatività e l'attivazione scaglionata fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto.^[2210] L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il controllo sintetico, a partire dai dati che affluiscono man mano che il servizio si attiva e dalla progressione differenziata della formazione degli elenchi.^[2211] L'analisi del valore dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione siciliana, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle Aziende e l'impostazione di un flusso uniforme dei dati di esito attraverso la relazione annuale prevista dalla legge.^[2212] La fase di avvio consente così di impostare correttamente la rilevazione fin dall'inizio, conducendo la regione, in modo programmato, da una valutazione fondata su dati esterni a una fondata in misura crescente su dati propri.^[2213] La sintesi è univoca: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con

un piano di acquisizione e consolidamento dei dati, e la condizione di regione in avvio impone di ancorare inizialmente la prova ai benchmark, valorizzando l’opportunità di una rilevazione ben progettata. La parte che segue affronta l’equità e l’impatto distributivo.^[2214]

Priorità di ricerca	Finalità	Rilevanza
Conti certificati delle dieci Aziende e delle AOU	Sostituire le stime per quota con dati reali	Massima
Consolidamento dei dati di esito del servizio attivo	Uniformare e completare l’evidenza propria	Massima
Tassi di intercettazione e costi evitati	Ridurre l’incertezza sulle grandezze aggregate	Alta
Efficacia clinica nel contesto locale	Corroborare il parametro più influente	Alta

Tabella F.3. Le priorità di ricerca derivanti dall’******analisi del valore dell’****** informazione.

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte G

Equità e impatto distributivo

Gradiente sociale, assi territoriali del divario, barriere di accesso, costo-efficacia distributiva

Dominio dell’HTA · i pazienti e l’equità

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte affronta il dominio dell’equità, che la valutazione di tecnologia sanitaria tiene distinto dall’efficienza. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano i dati distributivi, ancorati alla Sicilia. La parte definisce il quadro dell’equità e il gradiente sociale (capitolo G.1); analizza i due assi territoriali del divario siciliano e le barriere di accesso (G.2); descrive gli strumenti attraverso cui il servizio agisce sull’equità (G.3); e presenta l’analisi di costo-efficacia distributiva con le sue implicazioni allocative (G.4). Il tratto distintivo della Sicilia è la doppia struttura del divario territoriale — centro e periferia entro le aree metropolitane di Palermo e Catania, e aree metropolitane contro province interne — cui si somma una marcata dimensione generazionale, propria di una regione giovane; l’intervento può ridurre tali divari, a condizione di un’allocazione modulata per il bisogno.

G.1 Il quadro dell’equità e il gradiente sociale

L’analisi distributiva costituisce un dominio proprio della valutazione, poiché un intervento efficiente nel complesso può nondimeno accrescere o ridurre le disuguaglianze; lo studio ne misura l’effetto con l’analisi di costo-efficacia distributiva.^{[2215][2216][2217][2218][2219][2220][2221][2222][2223][2224][2225][2226][2227][2228]} Il punto di partenza è il gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori.^[2229] A questo gradiente si sommano barriere di accesso economiche, geografiche e culturali, oltre allo stigma; nella Sicilia,

dove la componente straniera è contenuta, più rilevante della barriera culturale è quella generazionale, cui si aggiunge — tratto proprio del modello regionale — la barriera economica del ticket a carico del paziente, che le esenzioni attenuano ma non eliminano.^[2230]

G.2 I due assi del divario territoriale

La specificità distributiva della Sicilia risiede nella doppia struttura del divario territoriale, cui si aggiunge la dimensione generazionale.^[2231] Il primo asse è interno alle aree metropolitane di Palermo e Catania: accanto a quartieri meglio serviti si estendono periferie popolate con sacche di deprivazione socio-economica, dove la difficoltà di accesso e la minore disponibilità di offerta privata accrescono il bisogno non intercettato.^[2232] Il secondo asse separa le aree metropolitane e costiere dalle province interne: Enna e Caltanissetta, e le aree interne dell’isola, presentano una popolazione più anziana, a minore densità e con tendenze allo spopolamento, dove la rarefazione dei servizi, le distanze e la condizione insulare rendono l’accesso particolarmente difficoltoso.^[2233] La tabella seguente sintetizza i due assi e le leve di riequilibrio.

Asse del divario	Caratterizzazione	Leva di riequilibrio
Centro / periferia di Palermo e Catania	Periferie popolate con sacche di deprivazione e minore offerta privata	Sedi nelle Case della Comunità di periferia; allocazione pro-equità
Aree metropolitane / province interne e insulari	Enna, Caltanissetta e aree interne: popolazione più anziana, a minore densità, condizione insulare	Telepsicologia assistita; presenza programmata di primo livello
Disagio giovanile	Priorità del governo regionale, a basso ricorso spontaneo ai servizi	Intercettazione precoce; competenza dedicata agli adolescenti e ai giovani adulti

Tabella G.1. I due assi del divario territoriale siciliano, la dimensione generazionale e le leve di riequilibrio.

G.3 Gli strumenti dell’equità

Il servizio agisce sull’equità attraverso meccanismi precisi. La prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano parte delle barriere e indirizzano l’offerta verso chi ne è oggi escluso; nel modello siciliano, tuttavia, il servizio è soggetto a ticket, sicché il pieno effetto pro-equità dipende dal contenimento della compartecipazione e dall’efficacia delle esenzioni.^[2234] La telepsicologia assistita avvicina l’offerta alle province interne di Enna e Caltanissetta e alle periferie di Palermo e Catania, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, estendendo la copertura proprio dove l’accesso è più difficile.^[2235] La competenza nell’intercettare il disagio giovanile assicura che il servizio raggiunga adolescenti e giovani adulti, fascia a elevato bisogno e a basso ricorso spontaneo, mentre la competenza culturale resta necessaria nelle aree di maggiore insediamento straniero, pur meno centrale data la quota contenuta.^[2236]

G.4 La costo-efficacia distributiva e le implicazioni allocative

L’analisi di costo-efficacia distributiva indica che l’intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, poiché i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto.^[2237] Perché questo potenziale si realizzi, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle periferie metropolitane e alle province interne:

un’allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un’allocazione ponderata per il bisogno li riduce.^[2238] Va inoltre tenuto presente che, nella Sicilia, il canale della mobilità costituisce una leva di equità solo modesta per questo intervento, sicché l’equità si gioca prevalentemente sull’accesso interno; e che il ticket, se non calibrato, rischia di gravare proprio sulle fasce a minore capacità di spesa.^[2239] Esiste infine un rischio di iniquità inversa: se l’attivazione del servizio privilegiasse, per facilità organizzativa, le aree già meglio servite, l’effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell’allocazione, fin dalla formazione degli elenchi provinciali.^[2240] La sintesi è che l’intervento è favorevole all’equità su entrambi gli assi e sulla dimensione generazionale, a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno, che siano garantite la telepsicologia per le periferie e le aree interne e insulari e l’attenzione al disagio giovanile, e che il ticket sia calibrato con esenzioni efficaci; la raccomandazione è di orientare fin dall’avvio, nella formazione degli elenchi provinciali, un’allocazione pro-equità che dia di più dove il bisogno è maggiore.^[2241] La tabella seguente riepiloga l’impatto distributivo atteso.

Dimensione distributiva	Esito per la Sicilia
Efficienza complessiva	Intervento costo-efficace e dominante per paziente
Direzione dell’effetto distributivo	Favorevole all’equità: maggiori benefici nei gruppi a più alto bisogno
Condizione di realizzazione	Allocazione modulata per il bisogno (periferie e aree interne)
Strumenti abilitanti	Prossimità, telepsicologia, competenza generazionale; ticket calibrato con esenzioni
Rischio da prevenire	Iniquità inversa da allocazione; barriera economica del ticket non calibrato

Tabella G.2. L ‘*******impatto distributivo atteso dell’*******’intervento e le sue condizioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Competenza e forma dell’atto, rapporto di lavoro, governance, tutele etiche e protezione dei dati

Domini dell’HTA · aspetti giuridici, etici e organizzativi

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte affronta congiuntamente i domini giuridico, organizzativo ed etico, che la valutazione tiene distinti ma interdipendenti. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati alla Sicilia. La parte tratta il profilo giuridico — la competenza, la forma dell’atto, il rapporto di lavoro e i livelli essenziali (capitolo H.1); il profilo organizzativo — l’assetto e la governance del servizio (H.2); il profilo etico — le tutele a garanzia dei pazienti (H.3); e la sintesi dei tre profili (H.4). Il tratto distintivo della Sicilia emerge sul piano giuridico: a differenza del Lazio, ancora privo di legge, la regione dispone già di una disciplina vigente e di un decreto attuativo, sicché la condizione abilitante non è l’approvazione della legge, ma il passaggio dall’avvio al regime e la stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro.

H.1 Il profilo giuridico

La fattibilità dell'intervento dipende dal presidio congiunto dei tre profili, una debolezza in uno solo dei quali ne comprometterebbe l'esito.^{[2242][2243][2244][2245][2246][2247][2248][2249][2250][2251][2252][2253][2254][2255][2256][2257]} Sul piano giuridico, la materia si colloca nella competenza concorrente in tema di tutela della salute, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — originata dal giudizio sulla legge campana, di cui ha riconosciuto la legittimità — ne ha delimitato lo spazio regionale: entro questa cornice la Sicilia, regione a statuto speciale, ha esercitato il titolo a istituire il servizio con la legge regionale 18 del 2023.^[2258] Qui si colloca la specificità della regione: disponendo già della legge regionale 18 del 2023 e del decreto attuativo del novembre 2024, la decisione giuridica rilevante non è l'approvazione della legge, già compiuta, né l'emanazione del decreto, già emanato, ma il passaggio dall'avvio al regime.^[2259] Il rapporto di lavoro adottato è quello convenzionale su base libero-professionale, con iscrizione a un elenco provinciale secondo titoli e criteri definiti dal decreto e con un ticket a carico del paziente, da presidiare sul piano delle tutele e in attesa della definizione di un contratto collettivo nazionale.^[2260] Quanto ai livelli essenziali di assistenza, la psicologia delle cure primarie non vi è ancora esplicitamente ricompresa, e il servizio, sostenuto entro i vincoli dello statuto speciale e del piano di rientro, richiede la stabilizzazione su un finanziamento regionale stabile, a valere sull'impegno iniziale già disposto dalla legge.^[2261] Il servizio si inserisce coerentemente nella cornice degli standard territoriali e delle Case della Comunità,^[2262] e si rapporta ai Centri di Salute Mentale per integrazione e non per sovrapposizione, precedendoli e alleggerendoli.^[2263] La tabella seguente riepiloga i profili giuridici.

Profilo giuridico	Contenuto per la Sicilia
Competenza	Concorrente in tutela della salute; Corte Cost. 241/2021 (originata dalla legge campana) ha delimitato lo spazio regionale
Forma dell'atto	Legge regionale 18/2023 già vigente, Delibera 253/2024 e decreto attuativo 2024; servizio in avvio, da portare a regime
Rapporto di lavoro	Convenzionale libero-professionale con elenco provinciale e ticket a carico del paziente; manca un contratto collettivo nazionale
Livelli essenziali di assistenza	Non ancora ricompresi; statuto speciale (49,11%) e piano di rientro; impegno iniziale ~7,4 mln, da stabilizzare
Cornice territoriale	Decreto Ministeriale 77/2022; inserimento nelle Case della Comunità
Rapporto con i servizi specialistici	Integrazione con i Centri di Salute Mentale, che il servizio precede e alleggerisce

Tabella H.1. I profili giuridici del servizio nella Sicilia.

H.2 Il profilo organizzativo e la governance

Sul piano organizzativo, la strutturazione del servizio nella Sicilia si misura con un sistema esteso e insulare — nove Aziende Sanitarie Provinciali, numerose aziende ospedaliere e ad alta specializzazione — e con l'assenza di un'azienda regionale unica, sicché il coordinamento è in capo all'Assessorato regionale della Salute e la sfida centrale è garantire l'omogeneità attuativa fra le nove Aziende.^[2264] Il consolidamento poggia su una regia

regionale che coordina le Aziende, l’Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei; tale regia è in capo all’Assessorato regionale della Salute, attraverso i suoi Dipartimenti, cui spetta definire indirizzi operativi uniformi e impostare il sistema di monitoraggio comune, fondato sulla relazione annuale prevista dalla legge.^[2265] In questo quadro l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, che ha accompagnato l’elaborazione e l’attuazione della legge, concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione e alla vigilanza deontologica.^[2266] La tabella seguente sintetizza l’assetto organizzativo e di governance.

Elemento organizzativo	Assetto per la Sicilia
Articolazione del sistema	Nove Aziende Sanitarie Provinciali; aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e ad alta specializzazione
Coordinamento	In capo all’Assessorato regionale della Salute; assenza di un’azienda regionale unica
Sfida organizzativa	Omogeneità attuativa fra le nove Aziende in un sistema esteso e insulare
Regia della strutturazione	Indirizzi operativi uniformi e monitoraggio comune in capo all’Assessorato e ai suoi Dipartimenti
Soggetti coinvolti	Aziende, Ordine professionale, medicina generale e pediatria, atenei

Tabella H.2. L ‘*****assetto organizzativo e la governance dell*****’istituzione.

H.3 Il profilo etico

Sul piano etico, lo studio adotta cautele a tutela dei pazienti. Le situazioni che coinvolgono minori e persone vulnerabili sono presidiate impiegando gli strumenti di esito nei soli punteggi complessivi e indirizzando le situazioni di rischio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza entrare nel merito dei metodi clinici.^[2267] L’intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un’informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell’efficacia stessa del sostegno.^[2268] Gli strumenti di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, in conformità al quadro europeo e ai requisiti sui dispositivi medici,^[2269] il trattamento dei dati è conforme alla normativa e ispirato alla minimizzazione,^[2270] e la responsabilità delle decisioni cliniche resta interamente in capo al professionista, cui gli strumenti forniscono un ausilio non vincolante.^[2271]

H.4 Sintesi dei profili

La ricognizione dei tre profili conduce a una conclusione netta: il profilo giuridico, quello organizzativo e quello etico sono tutti presidiati, e la condizione abilitante dell’intervento non è, per la Sicilia, l’approvazione della legge — già in vigore — né l’emanazione del decreto attuativo, già emanato, ma il passaggio dall’avvio al regime e la stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro e dello statuto speciale. È questo il passaggio da cui dipende la piena operatività del servizio.^[2272] Definiti i profili, la parte che segue affronta l’attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

I cinque casi, il dimensionamento ex novo, le fasi di attuazione, i rischi e le mitigazioni

Five Case Model · la realizzabilità della decisione

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità dell'intervento, organizzandole secondo il modello a cinque casi della decisione di investimento pubblico. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati alla Sicilia. La parte espone i cinque casi (capitolo I.1); definisce il dimensionamento a partire dal nucleo di avvio e le fasi di attuazione (I.2); tratta il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma (I.3); analizza la sostenibilità finanziaria e organizzativa (I.4); e individua i rischi e le mitigazioni (I.5). Il tratto distintivo della Sicilia è che l'attuazione muove da un servizio già istituito e dotato di decreto attuativo, ma in fase di avvio: non l'istituzione, ma il passaggio dall'avvio al regime, condizionato non dall'approvazione di una legge — già in vigore — ma dalla formazione degli elenchi provinciali e dalla stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro e dello statuto speciale.

I.1 I cinque casi della decisione

Lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile.^{[2273][2274][2275][2276][2277][2278][2279][2280][2281][2282][2283][2284][2285][2286][2287][2288]} Il caso strategico è solido: l'istituzione del servizio è coerente con gli standard territoriali, con le Case della Comunità e con il Piano regionale di salute mentale, e nella Sicilia porta a regime il modello che la regione ha già istituito per legge e di cui ha già emanato il decreto attuativo.^[2289] Il caso economico rinvia ai risultati già esposti, nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di modesto disavanzo e un caso sociale fortemente positivo.^[2290] Il caso commerciale è già disciplinato e si avvale di un ampio bacino professionale alimentato dagli atenei siciliani, con psicologi selezionati attraverso gli elenchi provinciali secondo titoli e criteri definiti dal decreto.^[2291] Il caso finanziario presenta un costo contenuto, pari allo 0,3-0,5% del finanziamento sanitario regionale, da reperire però entro i vincoli dello statuto speciale e del piano di rientro, a valere sull'impegno iniziale già disposto dalla legge.^[2292] Il caso gestionale dipende da una regia regionale che, in assenza di un'azienda unica, coordini il sistema insulare delle nove Aziende.^[2293] La tabella seguente riepiloga i cinque casi.

Caso	Contenuto per la Sicilia
Strategico	Coerenza con DM 77/2022, Case della Comunità e programmazione salute mentale; passaggio a regime del modello già istituito per legge e con decreto attuativo
Economico	Rapporto beneficio-costi 3,9-5,5 a uno; dominanza per paziente; caso sociale fortemente positivo
Commerciale	Rapporto convenzionale già disciplinato; ampio bacino dagli atenei siciliani; elenchi provinciali con titoli e criteri del decreto
Finanziario	Costo 0,3-0,5% del FSR; statuto speciale (49,11%) e piano di rientro; impegno iniziale ~7,4 mln, da stabilizzare
Gestionale	Regia dell'Assessorato regionale per il coordinamento del sistema insulare, in assenza di azienda unica

Tabella I.1. I cinque casi della decisione di investimento pubblico.

I.2 Il dimensionamento dal nucleo di avvio e le fasi di attuazione

A differenza del Lazio, che dimensiona il servizio da zero, la Sicilia muove dal nucleo di avvio previsto dalla legge, dell'ordine di 110 psicologi, e lo estende verso un fabbisogno a regime dell'ordine di 1.030 psicologi nello scenario espansivo; l'estensione procede per gradi attraverso gli scenari conservativo, di base ed espansivo.^[2294] L'attuazione si articola perciò in tre fasi: una fase di formazione degli elenchi provinciali e di avvio operativo; una fase di estensione, nella quale la copertura si amplia progressivamente fra le Aziende; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato. La progressione differenziata della formazione degli elenchi fra le Aziende coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F.^[2295] La tabella seguente riepiloga le fasi.

Fase	Contenuto	Dimensionamento indicativo
Avvio	Formazione degli elenchi provinciali e avvio operativo	~ 110 psicologi (nucleo di avvio)
Estensione	Ampliamento progressivo della copertura fra le Aziende	verso ~ 520-780 incarichi
Regime	Dimensionamento adeguato al fabbisogno	fino a ~ 1.030 incarichi

Tabella I.2. Le fasi di attuazione e il dimensionamento progressivo.

I.3 Reclutamento, formazione e cronoprogramma

L'estensione richiede il reclutamento e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino professionale, i titoli e i criteri di valutazione già definiti dal decreto e gli atenei siciliani costituiscono una base favorevole, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze.^[2296] Il cronoprogramma si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; a differenza del Lazio, l'estensione non è subordinata all'approvazione di una legge — già in vigore — né all'emanazione del decreto — già emanato — ma alla formazione degli elenchi provinciali e alla stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro.^[2297]

I.4 La sostenibilità finanziaria e organizzativa

La sostenibilità finanziaria, nella Sicilia, ha per leva la stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli dello statuto speciale e del piano di rientro, a valere sull’impegno iniziale già disposto dalla legge, e il dimensionamento progressivo del servizio; il sistema, storicamente sotto-finanziato, presenta margini di consumo improprio ampi da recuperare, mentre l’eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe in futuro la stabilità.^[2298] La sostenibilità organizzativa dipende invece dalla capacità di garantire l’omogeneità attuativa fra le nove Aziende Sanitarie Provinciali in un sistema esteso e insulare privo di un’azienda regionale unica, e quindi dalla forza della regia dell’Assessorato regionale, dal ruolo dei suoi Dipartimenti e dalla chiarezza degli indirizzi operativi.^[2299] L’avanzamento è seguito mediante indicatori di processo raccolti attraverso la relazione annuale prevista dalla legge, che la fase di avvio consente di impostare fin dall’inizio in forma uniforme fra le nove Aziende.^[2300]

I.5 I rischi e le mitigazioni

L’attuazione presenta rischi propri della posizione siciliana: la disomogeneità attuativa fra le nove Aziende in un sistema insulare, la difficoltà di coordinamento in assenza di un’azienda unica e soprattutto il vincolo del piano di rientro e dello statuto speciale sulla disponibilità di un finanziamento stabile, cui si aggiunge l’esigenza di calibrare il ticket.^[2301] Tali rischi sono fronteggiati con una regia regionale forte e indirizzi operativi uniformi, con la progressione differenziata della formazione degli elenchi che consente un apprendimento progressivo, e con un’allocazione pro-eguità e un ticket calibrato che orientano l’estensione verso le aree a maggiore bisogno; la stabilizzazione del finanziamento e il sostegno dell’Ordine professionale concorrono a ridurre l’incertezza.^[2302] La sintesi è che l’intervento è attuabile e sostenibile, e che la leva propria della Sicilia è la formazione degli elenchi provinciali e la stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro: la regione muove da un nucleo di avvio già previsto, da un bacino professionale ampio e da una cornice normativa completa, sicché le condizioni di fattibilità sono complessivamente favorevoli, pur entro un vincolo di bilancio più stretto che altrove.^[2303] La tabella seguente riepiloga i rischi e le relative mitigazioni; la parte che segue affronta il monitoraggio e la valutazione ex post.

Rischio	Mitigazione
Disomogeneità attuativa fra le nove Aziende	Regia regionale forte; indirizzi operativi uniformi; monitoraggio comune
Coordinamento senza azienda unica	Regia dell’Assessorato regionale; sistema informativo uniforme progettato dall’inizio
Vincolo del piano di rientro e statuto speciale	Stabilizzazione su finanziamento stabile entro i vincoli; disegno per fasi; sostegno dell’Ordine
Allocazione non equa nell’estensione e barriera del ticket	Criteri di equità espliciti; estensione pro-eguità verso periferie e aree interne; ticket calibrato con esenzioni

Tabella I.3. I rischi dell’attuazione e le relative mitigazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte L

Monitoraggio e valutazione ex post

Disegno controfattuale prospettico, batteria di indicatori, cruscotto regionale e clausola valutativa

Inferenza causale quasi-sperimentale · la valutazione ex post

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Questa parte definisce il sistema di monitoraggio e la valutazione ex post dell'intervento, attraverso cui l'istituzione del servizio si traduce in apprendimento e rendicontazione. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e muta ciò che attiene al disegno valutativo locale. La parte espone le finalità e l'impianto della valutazione (capitolo L.1); il disegno controfattuale e i metodi di stima (L.2); la batteria degli indicatori, organizzata per categorie (L.3); il cruscotto regionale e la clausola valutativa (L.4); e la sintesi (L.5). Il tratto distintivo della Sicilia è che, essendo il servizio in fase di avvio, la valutazione può disporre di una linea di base anteriore all'attivazione, e la previsione di relazione annuale — già contenuta nella legge — va rafforzata e resa operativa anziché introdotta.

L.1 Finalità e impianto della valutazione

Il monitoraggio e la valutazione ex post servono a rendere conto dell'impiego delle risorse, ad apprendere dall'esperienza e a correggere il corso dell'attuazione; non sono un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l'istituzione del servizio diventa apprendimento istituzionale, ancorato a una clausola valutativa. [\[2304\]](#)[\[2305\]](#)[\[2306\]](#)[\[2307\]](#)[\[2308\]](#)[\[2309\]](#)[\[2310\]](#)[\[2311\]](#)[\[2312\]](#)[\[2313\]](#)[\[2314\]](#)[\[2315\]](#)[\[2316\]](#)[\[2317\]](#)[\[2318\]](#)[\[2319\]](#)[\[2320\]](#)[\[2321\]](#)[\[2322\]](#)

L'impianto distingue i tre livelli della struttura, del processo e dell'esito, in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti. [\[2323\]](#)

L.2 Il disegno controfattuale e i metodi

Il disegno della valutazione d'impatto costituisce, per la Sicilia, un punto di forza dello studio. Poiché il servizio è in fase di avvio e gli elenchi provinciali si completano in tempi differenziati, la valutazione può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le nove Aziende Sanitarie Provinciali sono impiegati a fini valutativi. [\[2324\]](#) A differenza delle regioni a servizio già consolidato, la Sicilia può rilevare una linea di base anteriore all'attivazione, e il diverso grado di formazione degli elenchi fra le Aziende consente di costruire termini di confronto interni, fondando la stima su dati propri progettati fin dall'inizio. [\[2325\]](#) L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, con la progressione differenziata della formazione degli elenchi a fornire la variazione necessaria all'identificazione. [\[2326\]](#)

L.3 La batteria degli indicatori

Il servizio è osservato attraverso una batteria di indicatori organizzata per categorie. Gli indicatori di struttura misurano la capacità installata — sedi, incarichi, ore, dotazione, copertura. [\[2327\]](#) Gli indicatori di processo misurano il funzionamento — prese in carico, attesa, colloqui, invio appropriato. [\[2328\]](#) Gli indicatori di esito clinico misurano il beneficio diretto — miglioramento, recupero, remissione. [\[2329\]](#) Gli indicatori di esito di sistema misurano l'effetto sul resto del sistema — pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri. [\[2330\]](#) Gli indicatori economici consentono di verificare ex post le stime e di sostituire i valori ricostruiti con quelli effettivi. [\[2331\]](#) Gli indicatori di equità, disaggregati per area e per fasce di età, verificano che il servizio riduca i divari fra centro e periferie delle aree urbane e fra aree metropolitane e province interne e insulari, con attenzione al

disagio giovanile e all’effetto del ticket sull’accesso.^[2332] Gli indicatori di qualità integrano la misurazione con la dimensione dell’esperienza.^[2333] Gli indicatori di mobilità, infine, sono monitorati ma costituiscono un esito atteso solo modesto, limitato alla frazione territorialmente intercettabile.^[2334] L’insieme conta dell’ordine di cinquantotto indicatori in otto categorie, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile.^[2335] La tabella seguente riepiloga le categorie.

Categoria	Contenuto (dell’ordine di 58 indicatori complessivi)
Struttura	Sedi attivate, incarichi, ore, dotazione, copertura del fabbisogno
Processo	Prese in carico, attesa al primo colloquio, colloqui per persona, invio appropriato
Esito clinico	Miglioramento, recupero, remissione (strumenti validati, punteggi complessivi)
Esito di sistema	Accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili, specialistica impropria
Economici	Costo, risparmi diretti, ricadute sociali, rapporto beneficio-costi su dati reali
Equità	Copertura e accesso per area (centro, periferie urbane, province interne e insulari) e per fasce di età; effetto del ticket
Qualità	Soddisfazione, appropriatezza, continuità del rapporto
Mobilità	Monitorata; esito atteso modesto (sola frazione territorialmente intercettabile)

Tabella L.1. Le otto categorie della batteria di indicatori.

L.4 Il cruscotto regionale e la clausola valutativa

Gli indicatori confluiscono in un cruscotto regionale aggiornato periodicamente, che rende trasparente l’andamento del servizio e ne consente la correzione; in assenza di un’azienda regionale unica, la titolarità del cruscotto è in capo all’Assessorato regionale della Salute e ai suoi Dipartimenti, che ne assicurano l’alimentazione uniforme da parte delle nove Aziende.^[2336] Lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa; a differenza del Lazio, la Sicilia dispone già di una previsione di relazione annuale nella legge regionale 18 del 2023, sicché il compito non è introdurla ma rafforzarla e renderla pienamente operativa.^[2337] La raccolta dei dati poggia sulla relazione annuale prevista dalla legge, da impostare fin dall’avvio in forma uniforme e interoperabile con la piattaforma informativa sanitaria regionale.^[2338] La valutazione si articola infine in un monitoraggio in itinere, che accompagna l’attivazione progressiva, e in una valutazione ex post a regime.^[2339] La tabella seguente riepiloga la governance valutativa.

Elemento della governance valutativa	Scelta per la Sicilia
Disegno d'impatto	Esperimento a cunei progressivi tra le nove Aziende, con linea di base anteriore all'attivazione
Linea di base	Rilevazione anteriore all'attivazione e progressione differenziata della formazione degli elenchi
Titolarità del cruscotto	Assessorato regionale e suoi Dipartimenti, con alimentazione uniforme dalle nove Aziende
Clausola valutativa	Relazione annuale già prevista dalla legge 18/2023; da rafforzare e rendere operativa; relazione all'Assemblea
Flusso informativo	Relazione annuale di legge; da impostare in forma uniforme e interoperabile con la piattaforma regionale
Tempi	In itinere (accompagnamento dell'attivazione) ed ex post (effetto a regime)

Tabella L.2. La governance della valutazione e il cruscotto regionale.

L.5 Sintesi del monitoraggio

La valutazione è la condizione per trasformare l'avvio del servizio in apprendimento, e la Sicilia può fondarla su una linea di base anteriore all'attivazione; perché ciò si realizzi, la relazione annuale già prevista dalla legge va rafforzata e resa operativa e il flusso informativo va impostato fin dall'inizio in forma uniforme fra le nove Aziende, valorizzando l'opportunità di una rilevazione ben progettata.^[2340] Definito il sistema di monitoraggio, la parte conclusiva compone i risultati dei diversi domini in una sintesi multidimensionale e formula le raccomandazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Composizione dei domini, analisi multi-criterio, raccomandazioni operative e conclusione

Analisi multi-criterio · dalla valutazione alla raccomandazione

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclude lo studio componendo i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo e traducendolo in raccomandazioni operative. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i contenuti, ancorati alla Sicilia. La parte richiama la sintesi per dominio (capitolo M.1); espone l'analisi multi-criterio e il confronto fra l'intervento e il non intervento (M.2); formula la raccomandazione principale e il dimensionamento (M.3); ne precisa le condizioni e la lacuna da colmare (M.4); e chiude con la collocazione nella serie e la conclusione (M.5). Il tratto distintivo della Sicilia percorre l'intera sintesi: è la regione post-

legislativa in avvio, a statuto speciale e ancora sotto piano di rientro, che, decima e ultima della serie, è chiamata non a istituire un servizio, ma a portarlo dall’avvio al regime, rendendo operativo un servizio già istituito per legge e dotato di decreto attuativo.

M.1 La sintesi per dominio

La parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini impiegando l’analisi multi-criterio, che integra in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie, ponderandole secondo criteri espliciti.^{[2341][2342][2343][2344][2345][2346][2347][2348][2349][2350][2351][2352][2353][2354][2355][2356]} Il quadro che emerge dai domini è coerente: il bisogno è ampio e radicato in una regione insulare ed estesa; l’efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida, con dati operativi propri ancora in formazione; il quadro economico distingue un caso finanziario di modesto disavanzo prossimo al pareggio da un caso sociale fortemente positivo; l’equità è favorevole su un doppio asse territoriale e sulla dimensione generazionale, a condizione che il ticket sia calibrato; la fattibilità è quella del passaggio dall’avvio al regime di un servizio già istituito; il monitoraggio può fondarsi su una linea di base anteriore all’attivazione.^[2357] La tabella seguente riepiloga il giudizio per dominio.

Dominio	Giudizio sintetico per la Sicilia
Bisogno e contesto	Ampio; regione insulare ed estesa, a statuto speciale, ancora sotto piano di rientro
Efficacia clinica	Evidenza internazionale solida; dati operativi propri ancora in formazione (servizio in avvio)
Valutazione economica	Caso finanziario di modesto disavanzo; caso sociale fortemente positivo
Equità	Favorevole su doppio asse (centro/periferie urbane; metropoli/aree interne e insulari) e sul disagio giovanile; ticket da calibrare
Fattibilità	Passaggio dall’avvio al regime di un servizio già istituito; bacino ampio; vincolo del piano di rientro
Monitoraggio	Disegno controfattuale su servizio in avvio, con linea di base anteriore e relazione annuale di legge

Tabella M.1. La sintesi dei domini della valutazione.

M.2 L’analisi multi-criterio

Il giudizio complessivo è formalizzato con l’analisi multi-criterio, che impiega otto criteri, ciascuno con un peso esplicito, e confronta l’intervento con l’alternativa del non intervento.^[2358] I pesi adottati — efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell’evidenza 10%, coerenza strategica 5% — sono comuni a tutta la serie.^[2359] La media ponderata dei punteggi dell’intervento è dell’ordine di 78,4 su 100, sostenuta dai punteggi elevati nel valore sociale, nell’equità e nel ritorno, e contenuta dai punteggi più bassi nella robustezza dell’evidenza — che riflette la fase di avvio, con dati propri ancora in formazione — e nell’impatto sul bilancio, condizionato dai vincoli del piano di rientro.^[2360] Il non intervento ottiene una media dell’ordine di 39,2 su 100, penalizzato in tutti i criteri sostanziali e sostenuto soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, oggi poco giustificata, poiché lascerebbe inattuato un servizio già istituito per legge.^[2361] L’intervento prevale dunque nettamente, con

uno scarto dell'ordine di trentanove punti; il punteggio si colloca fra i più elevati delle regioni esaminate, riflettendo una cornice normativa completa.^[2362] La prevalenza si mantiene al variare dei pesi entro intervalli ragionevoli, sicché la raccomandazione è robusta.^[2363] La tabella seguente riporta i punteggi per criterio.

Criterio	Peso	Intervento	Non interv.
Efficacia clinica	15%	80	30
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	85	25
Impatto sul bilancio e sostenibilità	15%	64	52
Equità	15%	85	28
Valore sociale	10%	88	25
Fattibilità	10%	78	84
Robustezza dell'evidenza	10%	62	55
Coerenza strategica	5%	84	26
Punteggio complessivo ponderato	100%	78,35	39,20

Tabella M.2. L'«*****analisi multi-criterio: punteggi dell'*****»intervento e del non intervento.

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Dalla convergenza dei domini e dall'analisi multi-criterio discende la raccomandazione principale: portare dall'avvio al regime il servizio di psicologia delle cure primarie già istituito, completando la formazione degli elenchi provinciali, stabilizzandone il finanziamento entro i vincoli del piano di rientro e dimensionandolo verso la copertura piena del fabbisogno, con un ticket calibrato; è la decisione che la Sicilia, dotata di legge e decreto attuativo, è chiamata a compiere per rendere pienamente operativo il servizio.^[2364] Quanto alla scala, si raccomanda di muovere dal nucleo di avvio, dell'ordine di 110 psicologi, e di procedere per gradi verso lo scenario conservativo, dell'ordine di 520 psicologi, quindi verso quello di base, dell'ordine di 780, e infine verso quello espansivo, dell'ordine di 1.030, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità.^[2365] La tabella seguente riepiloga le raccomandazioni operative.

Ambito	Raccomandazione operativa per la Sicilia
Atto di attuazione	Portare dall'avvio al regime il servizio; completare gli elenchi provinciali; stabilizzare il finanziamento entro i vincoli
Dimensionamento	Dal nucleo ~110 verso conservativo ~520; base ~780; espansivo ~1.030, per gradi
Allocazione	Pro-eguità, verso periferie urbane, province interne e insulari e disagio giovanile; ticket calibrato
Clausola valutativa	Rafforzare e rendere operativa la relazione annuale già prevista dalla legge; relazione all'Assemblea
Governance	Regia dell'Assessorato regionale; indirizzi uniformi; flusso informativo da impostare fin dall'avvio
Dati	Estrarre i conti certificati delle nove Aziende; impostare i dati di esito uniformi via relazione annuale

Tabella M.3. Le raccomandazioni operative.

M.4 Le condizioni e la lacuna da colmare

La raccomandazione è subordinata a condizioni precise: il rafforzamento e la piena operatività della relazione annuale già prevista dalla legge, l'adozione di un'allocazione pro-eguità, la calibrazione del ticket con esenzioni efficaci, una regia dell'Assessorato regionale e l'impostazione fin dall'avvio di un flusso informativo uniforme.

[2366] Resta inoltre da colmare, prima della presentazione esterna, la lacuna dei dati: l'estrazione dei conti certificati delle nove Aziende Sanitarie Provinciali e delle aziende ospedaliere e l'impostazione di un flusso uniforme dei dati di esito via relazione annuale consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive. [2367] Va infine ribadita la distinzione cardine: il caso finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, mentre il caso economico complessivo è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto. [2368]

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio sulla Sicilia è il decimo e ultimo della serie, dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria, Lazio e Campania, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, la Sicilia occupa una posizione propria — quella della regione post-legislativa in avvio, a statuto speciale e unica della serie ancora sottoposta a piano di rientro, che ha già istituito il servizio per legge e ne ha emanato il decreto attuativo — e che oggi è chiamata a portarlo dall'avvio al regime. [2369]

Coerentemente con l'impostazione dell'intero progetto, lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico, e adotta un rapporto beneficio-costi prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, per credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica. [2370] La decisione che lo studio sostiene è, in conclusione, di portare dall'avvio al regime il servizio di psicologia delle cure primarie già istituito, completando la formazione degli elenchi provinciali, stabilizzandone il finanziamento entro i vincoli del piano di rientro, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno, calibrando il ticket e rendendo pienamente operativa la relazione annuale: per la Sicilia, dotata di legge e decreto attuativo, ciò significa rendere effettivo un servizio già istituito, a beneficio della popolazione. [2371]

STUDIO REGIONALE · REGIONE SICILIANA · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Riforma «Psicologo di Base»: dal servizio in avvio alla strutturazione a regime

Appendici A-E

Corredo tecnico e documentale

Caso di riferimento, strumenti di esito, dati regionali, standard di reporting, glossario

Materiali a sostegno delle Parti da A a M

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l’orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità.^{[2372][2373][2374][2375][2376][2377][2378][2379][2380]} La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Servizio attivo ma parziale e a finanziamento transitorio (PNES); condizione di pre-strutturazione a regime
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per Azienda Sanitaria Locale/distretto
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudenziale	Riduzione per l’ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura.^[2381] La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l’analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato del Lazio, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.^[2382] La tabella seguente lo riepiloga.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 520	~ 780	~ 1.030
Costo del servizio	~ 29	~ 43	~ 57
Risparmi diretti (SSR)	~ 23	~ 36	~ 56
Ricadute economico-sociali	~ 90	~ 170	~ 255
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -6	~ -7	~ -1
Saldo complessivo (caso economico)	+84	+163	+254
Rapporto beneficio-costo complessivo	~3,9:1	~4,8:1	~5,5:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di 55.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell'esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario.^[2383] La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura.^[2384] La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a servizi specialistici; restituzione al medico curante	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori siciliani impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.^[2385]

Ambito	Valore regionale
Popolazione regionale	4.787.390 abitanti (Censimento ISTAT 2024), ~8,1% del totale nazionale; lieve calo; concentrazione su Palermo e Catania (~47,4%); stranieri ~4,3%; età media ~45,7 anni
Finanziamento del SSR	Dell'ordine di 10-11 miliardi di euro; statuto speciale (compartecipazione al 49,11% del fabbisogno); regione ancora sottoposta a piano di rientro
Mobilità sanitaria	Saldo fra i più passivi d'Italia (~250 milioni); fuga concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica; canale di recupero modesto per questo intervento (sola frazione territoriale)
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche dell'ordine di alcune decine di migliaia l'anno (proxy dai dati nazionali)
Farmaceutica	Consumo regionale delle categorie dei psicofarmaci
Salute mentale	~ 957.000 con disagio comune potenziale (proxy ~20%); utenza in carico ai servizi rapportata ai dati nazionali; disagio giovanile indicato come priorità dal governo regionale
Funzione attuale	Servizio in avvio: legge regionale (LR 18/2023), Delibera 253/2024 e decreto attuativo (DPRS novembre 2024); elenchi provinciali in formazione; due psicologi per distretto, con ticket; impegno iniziale ~7,4 mln; statuto speciale e piano di rientro

Tabella C.1. I valori regionali di ancoraggio della Sicilia.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione siciliana, e non estratti dai conti regionali certificati.^[2386] La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario
Dati del servizio in avvio	Prese in carico, sedute ed esiti da raccogliere via relazione annuale, da impostare in forma uniforme come fonte primaria
Liste di attesa	Tempi di attesa per l'accesso psicologico, per Azienda e per area

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica.^[2387] La tabella seguente li riepiloga.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell’evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell’intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista.^[2388] Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Valutazione rapida di efficacia relativa	Nucleo dell'HTA, che copre i primi quattro domini (problema, descrizione, sicurezza, efficacia)
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER)	Rapporto tra costo aggiuntivo e guadagno di salute, confrontato con una soglia
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra gruppi a diversa esposizione
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità a minore esposizione
Disegno a cunei progressivi	Disegno controfattuale impiegato nella Sicilia, ove il servizio è in avvio, fondato sulla progressione differenziata della formazione degli elenchi tra le nove Aziende Sanitarie Provinciali, con una linea di base anteriore all'attivazione che la fase di avvio consente di rilevare

Termine	Definizione
Analisi e verifica d’impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta a riferire all’Assemblea regionale sui risultati della riforma; nella Sicilia la relazione annuale è già prevista dalla legge regionale 18/2023, da rafforzare e rendere pienamente operativa
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell’implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall’impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d’ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l’intensità dell’intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; nella Sicilia il saldo è fra i più passivi d’Italia, ma poiché la fuga è ospedaliero-chirurgica il canale del recupero è modesto per questo intervento, limitato alla frazione territorialmente intercettabile
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni
Indice di vecchiaia	Rapporto tra ultrasessantacinquenni e giovani sotto i quindici anni; nella Sicilia con età media intorno a 45,7 anni e province interne (Enna, Messina) più anziane dei poli urbani di Palermo e Catania
Peso morto	Quota dell’esito che si sarebbe verificata anche senza l’intervento
Ticket (compartecipazione)	Quota di costo a carico del paziente; nel modello siciliano è previsto un ticket, con esenzioni per le fasce protette, da calibrare perché non ostacoli l’accesso
Statuto speciale e piano di rientro	La Sicilia è regione a statuto speciale, con compartecipazione al 49,11% del fabbisogno sanitario, ed è ancora sottoposta a piano di rientro: un vincolo di bilancio più stretto sulla disponibilità di risorse stabili

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

Sardegna — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Autonoma della Sardegna

Progetto «Psicologo di Base» — Riforma «Psicologo di Base»: dal Dipartimento sperimentale alla strutturazione a regime. Applicazione del telaio integrato in undici parti (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per la Sardegna, che applica alla regione il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria, al Lazio, alla Campania e alla Sicilia. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati alla Sardegna. Nell'architettura adottata questa parte precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). La Sardegna occupa nella serie una posizione propria: ha previsto il servizio in una legge di riforma sanitaria, con un modello dipartimentale istituito in via sperimentale, ma il Dipartimento è attivo soltanto nell'Azienda di Sassari, sicché la valutazione non riguarda l'opportunità di introdurlo, ma la sua piena attivazione e il passaggio a regime.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie della Sardegna, inteso come piena attivazione e passaggio a regime di una funzione che la regione ha già previsto per legge, istituendolo in via sperimentale, e che è ad oggi attivo presso la sola Azienda di Sassari.^[2389] Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sulla consolidazione e l'estensione del servizio. La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante, per la Sardegna, non è istituire il servizio, già previsto per legge, ma attivarlo pienamente e condurlo a regime, estendendone il Dipartimento alle otto Aziende socio-sanitarie locali e dimensionandolo, dall'attuazione iniziale alla copertura sistematica del fabbisogno, disponendo la copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione, entro i vincoli di una regione a statuto speciale che si autofinanzia la sanità e registra il più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale.^[2390] Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala. Va segnalato sin d'ora che l'attuazione iniziale, limitata alla sola Azienda di Sassari, si colloca al di sotto dello stesso scenario conservativo qui considerato, che rappresenta invece il regime verso la copertura piena.

Coerentemente con la tradizione della valutazione di tecnologia sanitaria, lo studio è multidimensionale e non riduce la questione a un calcolo di costi. La popolazione di riferimento è ampia e in larga parte non intercettata: alla quota di disagio psichico comune o sottosoglia, dell'ordine di 312.000 persone, si somma un'utenza specialistica in carico ai servizi, in un quadro segnato da componenti convergenti — il bisogno dell'età adulta e anziana e della cronicità, prevalente in una delle regioni più anziane d'Italia, il disagio connesso allo

spopolamento delle aree interne, e il disagio giovanile e socio-economico nei due poli urbani di Sassari e Cagliari — cui si aggiungono i divari di accesso di una regione insulare a bassa densità, la pressione delle liste di attesa e la sotto-dotazione del sistema aggravata dal disavanzo strutturale.^[2391] La valutazione di un intervento rivolto a una popolazione di tale ampiezza, e collocato a monte del sistema dei servizi, richiede di considerare congiuntamente l’efficacia clinica, l’impatto economico diretto e sociale, l’equità di accesso, la sostenibilità organizzativa e i profili giuridici.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi — popolazione, intervento, confronto, esiti, tempi e contesto. La popolazione è costituita dai residenti sardi con bisogno psicologico comune, e in seconda istanza dall’intera popolazione per gli effetti di sistema. L’intervento è il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, condotto dall’attuazione parziale alla piena operatività a regime. Il confronto è la condizione attuale, nella quale il Dipartimento è attivo nella sola Azienda di Sassari. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l’orizzonte pluriennale degli esiti dall’orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è il Servizio sanitario della Sardegna, con le sue otto Aziende socio-sanitarie locali, l’Azienda regionale della salute, le aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, e la rete delle Case della Comunità in costruzione.^[2392] La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per la Sardegna
Popolazione	Residenti sardi con disagio psichico comune (~312.000); in seconda istanza l’intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie (modello dipartimentale, S.C. nelle ASL), primo livello e filtro, condotto a regime (~170/250/340 psicologi); dall’attuazione parziale alla copertura sistematica
Confronto	Condizione attuale: Dipartimento istituito in via sperimentale e attivo nella sola Azienda di Sassari; non ancora attivato nelle altre sette Aziende
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali (produttività, benessere); di sistema (accessi impropri, liste di attesa)
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Servizio sanitario regionale della Sardegna; otto Aziende socio-sanitarie locali, Azienda regionale della salute (ARES), aziende ospedaliere, rete delle Case della Comunità in costruzione

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell’HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell’OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio.^[2393] In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l’intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità. La definizione di questo impianto — cornici, metodi e standard — è ciò che distingue lo studio da una relazione argomentativa e ne fa una valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo della finanza pubblica.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni. Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e il Dipartimento nella sua attuazione sperimentale e parziale come comparatore.^[2394] Le unità di analisi sono la regione e, in disaggregazione, le Aziende socio-sanitarie locali e i distretti, per dare conto anche dei divari territoriali interni, segnatamente fra i due poli urbani di Sassari e Cagliari e le aree interne e spopolate dell'Isola.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Condizione attuale: Dipartimento istituito in via sperimentale, attivo nella sola Azienda di Sassari
Unità di analisi	Regione, con disaggregazione per Azienda socio-sanitaria locale e distretto
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso.^[2395] Tale prudenza assume, per la Sardegna, un rilievo particolare. Regione a statuto speciale, essa si autofinanzia integralmente la sanità con risorse dei residenti — sicché i tetti nazionali di spesa non le si applicano, purché rispetti il pareggio di bilancio — ma registra il più elevato disavanzo sanitario fra le regioni a statuto speciale e una spesa farmaceutica nettamente superiore alla media nazionale. Sul versante della mobilità, presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, concentrato nei ricoveri ad alta complessità e nelle terapie oncologiche — una mobilità dettata da necessità — e non nella domanda psicologica, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente. Ne consegue un saldo diretto lievemente negativo ma prossimo al pareggio — meno sfavorevole di quanto il vincolo di bilancio lascerebbe temere, poiché il sistema sardo, a lungo sotto-finanziato, presenta un consumo improprio più ampio da recuperare, mentre il modello dipartimentale è integralmente gratuito — e il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi.^[2396] Va inoltre dichiarato, già in questa sede, che le grandezze economiche impiegate sono allo stato in parte ricostruite a partire dai conti nazionali per quota di popolazione, e

non estratte dai conti regionali certificati; poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, la Sardegna dispone di una base di dati operativi propri limitata, e lo studio poggia per l'efficacia sui benchmark internazionali, mentre l'attivazione progressiva del Dipartimento nelle otto Aziende costituirà la fonte primaria da consolidare. [2397]

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post. [2398] Per la Sardegna il disegno controfattuale assume una forma propria: poiché il Dipartimento si estenderà in tempi differenziati dalle Aziende già dotate, a partire da Sassari, alle restanti, esso può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, con l'ordine e i tempi di attivazione del Dipartimento fra le otto Aziende impiegati a fini valutativi e l'effetto causale stimato dai metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico. [2399] La tabella seguente colloca ciascuna metodologia nella sua sede.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione, le otto Aziende socio-sanitarie locali, l'Azienda regionale della salute, le aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei di Cagliari e

Sassari. A differenza della Sicilia, la Sardegna dispone di un'azienda regionale di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo, l'ARES, costituita dalla legge di riforma, accanto al coordinamento dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità.^[2400] Poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente e la rete delle Case della Comunità è in costruzione, la sfida del governo non è istituire il servizio, ma attivarlo pienamente e condurlo a regime, estendendo il Dipartimento alle otto Aziende e garantendo l'omogeneità attuativa in un sistema insulare a bassa densità: è il tratto che distingue la Sardegna, e che la valutazione assume come punto di partenza.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza, con la piattaforma informativa sanitaria regionale quale infrastruttura per la raccolta uniforme.^[2401] Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici.^[2402] Sul piano etico, infine, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti.^[2403] Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, e sotto queste garanzie, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto della Sardegna.

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto della Sardegna. La struttura è quella già adottata per le altre regioni della serie, e mutano soltanto i dati, ancorati alla regione. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall'epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l'intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico della Sardegna: non un servizio da istituire, ma un servizio già previsto per legge con un modello dipartimentale e attivato nella sola Azienda di Sassari, da portare a piena attivazione e a regime in una regione insulare, a bassa densità, fra le più anziane d'Italia, a statuto speciale e con il più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale.

B.1 Quadro demografico

La Sardegna conta 1.562.381 residenti, pari a circa il 2,7% della popolazione nazionale, in calo di 8.072 unità (-0,5%) per effetto di un saldo naturale fortemente negativo e di un saldo migratorio interno negativo, e con nessuna provincia in crescita.^[2404] La struttura per età è fra le più anziane d'Italia, con un'età media salita a 49,2 anni: Sassari e Cagliari sono le province più giovani, Oristano e il Sud Sardegna le più anziane, e nei piccoli comuni interni l'età media supera i cinquantuno anni.^[2405] La componente straniera, pari al 3,4%, è fra le più contenute del Paese.^[2406] La distribuzione è concentrata sui due poli maggiori: le province di Sassari e Cagliari raccolgono insieme il 56,9% dei residenti — le sole oltre le quattrocentomila unità — seguite dal Sud Sardegna con il 21,1%.^{[2407][2408]} La tabella seguente ne riepiloga il profilo.

Indicatore	Valore per la Sardegna
Popolazione (Censimento 2024)	1.562.381 (~2,7% del totale nazionale); in calo (-8.072, -0,5%) per saldo naturale fortemente negativo e migratorio interno negativo
Età media e struttura	~ 49,2 anni, fra le più anziane d'Italia; Sassari e Cagliari più giovani (48,5/48,8), Oristano e Sud Sardegna più anziane (50,6/50,3)
Componente straniera	3,4% dei residenti (~54.000), fra le più contenute del Paese
Distribuzione territoriale	Sassari (471.957, 30,2%) e Cagliari (417.532, 26,7%) insieme 56,9%; Sud Sardegna 21,1%; solo 17,1% nei due comuni >100.000
Profilo territoriale	Due poli urbani (Sassari, Cagliari) con disagio giovanile e socio-economico; vaste aree interne (Oristano, Nuoro, Sud Sardegna) anziane e in spopolamento
Articolazione sanitaria	Otto Aziende socio-sanitarie locali, Azienda regionale della salute (ARES), aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie

Tabella B.1. *Profilo demografico e socio-economico della Sardegna.*

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale nella Sardegna è ampio e sospinto da una struttura demografica fra le più anziane d'Italia, distribuita su un territorio insulare a bassa densità. Proiettando i tassi di prevalenza nazionali, la quota di disagio psichico comune o sottosoglia si colloca nell'ordine di 312.000 persone, in larga parte non intercettate, tanto più in una fase in cui il Dipartimento è attivo nella sola Azienda di Sassari.^[2409] A questa quota si somma un'ampia utenza specialistica in carico ai servizi, su un territorio che presenta una specificità propria: ha previsto il Dipartimento in una legge di riforma, istituendolo in via sperimentale, e lo ha attivato nella sola Azienda di Sassari.^[2410] Tre componenti orientano la domanda. La prima e più caratterizzante è il bisogno dell'età adulta e anziana e della cronicità, accentuato nelle province interne e più anziane.^[2411] La seconda è il disagio giovanile e socio-economico nei due poli urbani di Sassari e Cagliari.^[2412] La terza è il disagio connesso allo spopolamento e all'isolamento delle aree interne.^[2413] È la combinazione — regione insulare a bassa densità e molto anziana, attuazione ancora parziale e disavanzo strutturale — a distinguere il fabbisogno sardo.^[2414] La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche significativi e resi più onerosi dalle distanze.^[2415]

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone, nella Sardegna, un'offerta ancora parziale ma già fondata su una previsione di legge: il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie è previsto dalla legge regionale 24 del 2020 (articolo 37), che lo istituisce in via sperimentale, e disciplinato dalla deliberazione di Giunta 9/22 del 2022; il modello è dipartimentale e strutturale, con Strutture Complesse di Psicologia territoriale di base interne a ciascuna Azienda, psicologi a rapporto di dipendenza e senza ticket, ma l'attivazione è subordinata alla copertura finanziaria e finora limitata all'Azienda di Sassari.^[2416] Il fabbisogno a regime è stimato nell'ordine di 340 psicologi nello scenario espansivo, e l'Ordine professionale regionale, che ne ha sollecitato l'inserimento

nella legge, ne sostiene la piena attivazione.^[2417] La copertura attuale corrisponde dunque alla sola Azienda di Sassari: non un servizio da istituire, ma un servizio da attivare pienamente, estendere alle otto Aziende e dimensionare.^[2418] La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per la Sardegna
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 312.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	Ampia (alcune decine di migliaia, stima rapportata ai dati nazionali)
Offerta territoriale attuale	Dipartimento istituito in via sperimentale (LR 24/2020 art. 37, DGR 9/22); modello dipartimentale, dipendente, senza ticket; attivato nella sola Azienda di Sassari
Fabbisogno stimato a regime	~ 340 psicologi nello scenario espansivo (170-250 negli altri scenari)
Copertura attuale del fabbisogno	Dipartimento attivo nella sola Azienda di Sassari (sette Aziende non ancora attivate)

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, nella Sardegna, si gioca su due assi. Il primo, più caratterizzante, separa i due poli urbani di Sassari e Cagliari dalle vaste aree interne di Oristano, Nuoro e del Sud Sardegna, più anziane, in forte spopolamento e penalizzate dalle distanze e dalla condizione insulare. Il secondo è interno ai poli urbani, fra i quartieri meglio serviti e le periferie con sacche di deprivazione.^[2419] Su questi divari il Dipartimento agisce in funzione di equità: avvicina l'offerta alle aree interne mediante la telepsicologia assistita — dove la sola presenza di un primo livello accessibile è già un atto di riequilibrio — e, assorbendo a monte la domanda appropriata, libera capacità specialistica e contribuisce a contenere i tempi di attesa, in un sistema sotto-dotato; il modello dipartimentale, integralmente gratuito, non oppone all'accesso delle fasce più fragili la barriera di un ticket, a differenza del modello convenzionale adottato dalla Sicilia.

B.5 I servizi e i flussi

Il Servizio sanitario della Sardegna dispone di risorse complessive dell'ordine di 3,5 miliardi di euro; in quanto regione a statuto speciale, la Sardegna si autofinanzia integralmente la sanità con risorse dei residenti, sicché i tetti nazionali di spesa non le si applicano, purché rispetti il pareggio; registra tuttavia il più elevato disavanzo sanitario fra le regioni a statuto speciale e una spesa farmaceutica nettamente superiore alla media nazionale.^[2420] Il profilo di mobilità è passivo, dell'ordine di cento milioni di euro l'anno; poiché però la fuga riguarda i ricoveri ad alta complessità e le terapie oncologiche — una mobilità dettata da necessità — il canale del recupero è per questo intervento solo modestamente pertinente.^[2421] L'architettura dei servizi poggia su otto Aziende socio-sanitarie locali, sull'Azienda regionale della salute con funzioni di coordinamento, su aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, e su una rete territoriale di Case della Comunità in costruzione, su cui il Dipartimento andrà pienamente innestato. La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per la Sardegna
Finanziamento del Servizio sanitario regionale	~ 3,5 miliardi di euro; statuto speciale autofinanziante (tetti non applicabili); più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale; spesa farmaceutica sopra la media
Mobilità sanitaria	Saldo passivo ~100 milioni l'anno (~10% della spesa per ricoveri); fuga oncologica e ad alta complessità (necessità); canale modesto per questo intervento
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche significativi (alcune decine di migliaia l'anno, stima rapportata ai dati nazionali)
Architettura dei servizi	Otto Aziende socio-sanitarie locali, Azienda regionale della salute (ARES) di coordinamento, aziende ospedaliere; rete delle Case della Comunità in costruzione
Margine di azione principale	Piena attivazione ed estensione alle otto Aziende, liste di attesa, accesso delle aree interne e spopolate, bisogno anziano e cronicità, intercettazione precoce

Tabella B.3. I servizi e i flussi del Servizio sanitario regionale rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice già acquisita sul piano normativo: la Sardegna ha previsto il Dipartimento con la legge regionale 24 del 2020 di riforma del sistema sanitario (articolo 37), istituendolo in via sperimentale, e ne ha definito l'assetto con la deliberazione di Giunta 9/22 del 2022.^[2422] La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera; sul piano regionale opera entro i vincoli dello statuto speciale e di un disavanzo strutturale. La decisione rilevante, in questo contesto, non è istituire una funzione, già prevista, ma attivarla pienamente, disporre la copertura finanziaria cui la legge la subordina, estenderla alle otto Aziende e dimensionarla: è il tema che le parti successive sviluppano, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello, oggetto della Parte C.

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello, secondo il secondo dominio della valutazione. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico della Sardegna emerge con nettezza: l'intervento non è da istituire, ma da attivare pienamente a partire da un Dipartimento previsto per legge con un modello dipartimentale e attivato nella sola Azienda di Sassari, di cui la regione deve estendere alle otto Aziende, avvalendosi del coordinamento dell'ARES, il modello, il sistema informativo e il monitoraggio.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire; nella Sardegna tale funzione è prevista dalla legge regionale 24 del 2020

(articolo 37).^[2423] La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato, attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria.^[2424] Il bisogno potenziale cui la catena si rivolge è dell'ordine di 312.000 persone con disagio comune.^[2425] La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per la Sardegna
Bisogno	~ 312.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato
Attività	Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie: intercettazione precoce, intervento breve, filtro
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte
Esito sociale	Recupero di produttività e di funzionamento, e minor carico familiare
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo delle cure primarie nelle Case della Comunità e nei distretti, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impianto della legge regionale 24 del 2020 (articolo 37) e della deliberazione di Giunta 9/22 del 2022, che configurano un modello dipartimentale e strutturale: Strutture Complesse di Psicologia territoriale di base interne a ciascuna Azienda, con psicologi a rapporto di dipendenza e senza ticket a carico del paziente. La Sardegna presenta qui una specificità: il Dipartimento è stato attivato nella sola Azienda di Sassari. A differenza della Sicilia, la regione dispone di un'azienda regionale di coordinamento, l'ARES, sicché estendere il Dipartimento alle otto Aziende in modo omogeneo — in un territorio insulare a bassa densità — è la sfida organizzativa principale, agevolata dal coordinamento dell'ARES.^[2426] La rete territoriale delle Case della Comunità, in costruzione, è l'infrastruttura su cui il servizio andrà pienamente innestato. Il funzionamento segue il principio dell'intensità crescente: l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio.^[2427]

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l'accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, una valutazione iniziale con progetto clinico individuale, un ciclo di colloqui brevi con programma di sostegno personalizzato e, nei casi che lo richiedono, l'invio appropriato ai servizi specialistici secondo criteri definiti; esso è in via di estensione dalle Aziende già dotate del Dipartimento, a partire da Sassari, alle restanti, e affronta i quadri più frequenti, dalla sintomatologia ansioso-depressiva ai problemi di adattamento e psicosomatici.^[2428] Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi e la scala a sette voci per il disturbo d'ansia generalizzata.^[2429] Particolare cura è dedicata alla

sicurezza: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. [2430] Gli esiti del percorso si articolano in quattro categorie, riepilogate nella tabella seguente. [2431]

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso (gli esiti economici e sociali sono trattati nella Parte E).

C.4 Il sistema informativo e l'interoperabilità

La registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con la piattaforma informativa sanitaria regionale e con il fascicolo sanitario elettronico, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. Il coordinamento informativo è agevolato dalla presenza dell'Azienda regionale della salute (ARES), che assicura funzioni tecnico-amministrative centralizzate, e deve garantire fra le otto Aziende l'uniformità della rilevazione man mano che il Dipartimento vi viene attivato. [2432] La raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito non è un adempimento accessorio, ma il presupposto della clausola valutativa e del disegno controfattuale; poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, la Sardegna ha l'opportunità di impostare il flusso fin dall'inizio in forma uniforme fra le otto Aziende, avvalendosi del coordinamento dell'ARES e progettando correttamente la rilevazione prima della piena operatività anziché doverla ricostruire ex post. [2433]

C.5 Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, e mai come sua sostituzione. Il triage e lo screening assistiti supportano l'indirizzamento e l'individuazione precoce sotto costante supervisione clinica, senza alcun automatismo decisionale. [2434] Gli strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica forniscono un ausilio non vincolante, di cui il professionista resta pienamente responsabile. [2435] L'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo alla relazione clinica. [2436] La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono, nella Sardegna, lo strumento per garantire l'accesso nelle vaste aree interne e spopolate di Oristano, Nuoro e del Sud Sardegna e nelle periferie dei poli urbani di Sassari e Cagliari, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza. [2437] I dispositivi terapeutici digitali, infine, sono interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici. [2438] La tabella seguente ne riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle aree interne spopolate e nelle periferie dei poli urbani; continuità	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini presso gli atenei sardi di Cagliari e Sassari; il livello post-universitario specialistico attraverso una formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, comprensiva della competenza per l'età anziana e la cronicità, prioritaria in una delle regioni più anziane d'Italia, e per il disagio giovanile nei poli urbani; il livello continuo attraverso l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e l'educazione continua in medicina; il livello dell'affiancamento operativo attraverso il tutoraggio sul campo e l'inserimento graduale con supervisione.^[2439] A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in ciascuno di essi e dedicata alla selezione e all'uso appropriato degli strumenti digitali, all'interpretazione degli esiti e alla conformità, sostenuta dalla piattaforma informativa sanitaria regionale.^[2440] La Sardegna presenta qui un elemento di metodo: l'Ordine professionale regionale ha già promosso una formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, base su cui innestare il percorso formativo del Dipartimento in via di attivazione. Definiti l'intervento e il suo modello, la parte che segue ne esamina l'efficacia e l'evidenza.

Livello	Contenuto	Soggetti e modalità
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio	Atenei sardi (Cagliari, Sassari)
2. Post-universitario specialistico	Psicologia delle cure primarie: modelli organizzativi, collaborazione, misure di esito, competenza per l'età anziana e la cronicità e giovanile	Formazione promossa dall'Ordine regionale
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza	Educazione continua in medicina
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale	Tutor aziendali; supervisione
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità	Moduli in tutti i livelli

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte affronta il quarto dominio della valutazione, l'efficacia clinica, e ne ricostruisce la base di evidenza. Come per le regioni precedenti, il corpo dell'evidenza internazionale è invariante, poiché l'efficacia di un intervento clinico non muta con i confini regionali; muta invece la base di evidenza locale, ed è qui che la Sardegna presenta un tratto proprio. La parte espone il metodo della revisione e i risultati di efficacia (capitolo D.1); ne gradua la qualità e ne dichiara una cautela economica essenziale (D.2); presenta i benchmark internazionali (D.3); e discute le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale sarda (D.4).

Quest'ultima presenta una condizione propria: poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, la Sardegna dispone di dati di esito propri limitati, sicché lo studio si fonda, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, mentre l'evidenza locale si costituirà attraverso il monitoraggio del Dipartimento man mano che raggiunge il regime.

D.1 Il metodo della revisione e l'evidenza di efficacia

La sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE, considerando studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale, con preferenza per le fonti più recenti.^[2441] Il nucleo dell'evidenza proviene dal modello della cura collaborativa, di cui lo studio fondativo ha documentato che circa la metà dei pazienti trattati conseguiva una riduzione sostanziale dei sintomi a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura usuale.^[2442] La robustezza del risultato è confermata dalla meta-analisi su cinquantasette studi controllati, con un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a poco meno di un terzo di deviazione standard,^[2443] e da una più recente revisione di quarantadue implementazioni, che documenta riduzioni rilevanti della depressione e dell'ansia e una contrazione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri.^[2444] Sul versante dei dati reali, il programma inglese delle terapie psicologiche registra, su scala di oltre un milione di persone

l’anno, un tasso di recupero del 50,2% e un miglioramento affidabile di oltre due terzi, con completezza dei dati di esito superiore al 98%.^[2445] Anche le sintesi più caute confermano un effetto di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante sull’intera popolazione.^[2446]

D.2 La qualità dell’evidenza e una cautela economica

La graduazione della certezza secondo il sistema GRADE colloca l’efficacia clinica dell’integrazione psicologica nelle cure primarie su un livello da moderato a elevato per i disturbi comuni, mentre la certezza è più eterogenea e minore per gli esiti economici, in particolare per quelli di sistema.^[2447] Da questa graduazione discende una cautela che lo studio adotta come principio di onestà intellettuale, e che merita di essere enunciata senza attenuazioni: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l’intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero. Ciò significa che il valore economico del modello non può essere fondato sui risparmi sanitari diretti, ma poggia in misura preponderante sui ritorni sociali. È una cautela che, lungi dall’indebolire il caso sardo, ne corrobora la coerenza interna, poiché il caso economico della Sardegna — come si vedrà nella Parte E — è fondato anch’esso sulle ricadute sociali, e non su un risparmio diretto che la regione non potrebbe rivendicare con certezza statistica.^[2448]

D.3 I benchmark internazionali

L’evidenza si concretizza in quattro programmi nazionali consolidati, che costituiscono i riferimenti per il disegno del servizio. Il programma inglese delle terapie psicologiche è il riferimento principale per l’organizzazione: servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell’ordine del 50% e monitoraggio degli esiti pressoché completo.^[2449] Il modello olandese integra una figura di supporto psicologico nello studio del medico di base, adottata dalla maggioranza dei medici, con ruolo complementare alla specialistica.^[2450] Il modello australiano, a invio esterno, ha innalzato di oltre dieci punti la quota di popolazione in trattamento.^[2451] Il modello statunitense della cura collaborativa, validato da oltre novanta studi controllati, documenta riduzioni rilevanti della depressione e dei ricoveri.^[2452] La tabella seguente ne riepiloga i tratti salienti.

Programma	Modello	Risultati principali
Regno Unito (NHS Talking Therapies)	Servizio integrato a intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio esiti >98%; >1,3 milioni/anno
Paesi Bassi (POH-GGZ)	Supporto psicologico nello studio del medico di base	Adozione da ~tre quarti dei medici; ruolo complementare
Australia (Better Access)	Invio esterno a professionisti	Popolazione in trattamento dal 35% al 46%
Stati Uniti (Collaborative Care)	Équipe integrata con monitoraggio	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione, -41% ricoveri

Tabella D.1. I benchmark internazionali dell’integrazione della salute mentale nelle cure primarie.

D.4 Le esperienze italiane, la trasferibilità e l'evidenza locale

Sul piano nazionale, il quadro comprende i servizi avviati nelle regioni dotate di legge — fra cui la Campania, prima a istituire e attivare il servizio — e le esperienze pilota fondate su campioni limitati. La Sardegna, che ha previsto il Dipartimento con la legge regionale 24 del 2020 (articolo 37) istituendolo in via sperimentale, vi si colloca come regione ad attuazione parziale.^[2453] Più in generale, i risultati internazionali provengono da sistemi diversi per organizzazione e finanziamento, e la loro trasposizione richiede validazione locale, evitando di trasferire meccanicamente le stime, soprattutto quelle economiche.^[2454] È qui che la posizione della Sardegna presenta una condizione propria, da dichiarare con franchezza: poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, l'evidenza locale è allo stato prevalentemente prospettica, e si costituirà attraverso il monitoraggio del Dipartimento, di cui l'Azienda di Sassari offre un primo nucleo.^[2455] La condizione della regione è dunque di costruire l'evidenza locale: la Sardegna dispone della previsione normativa, dell'infrastruttura informatica regionale, del coordinamento dell'ARES e della rete delle Case della Comunità in costruzione, e può impostare fin dall'inizio una rilevazione uniforme fra le otto Aziende, generando dati propri solidi man mano che il Dipartimento si struttura a regime.^[2456] Una precisazione di metodo, infine, accompagna l'intero studio a garanzia della sua credibilità. Alcune cifre di larga circolazione — il rapporto di quattro a uno, l'affermazione per cui un euro ne genererebbe dieci, il rapporto di due e mezzo a uno talvolta richiamato in sede regionale — sono semplificazioni divulgative. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, e lo studio adotta prudenzialmente un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,8 a 5,5 a uno.^[2457] Su questa base di evidenza, graduata e dichiarata nei suoi limiti, poggia la valutazione economica della Parte E.

Parte E — Valutazione economica

Questa parte affronta il quinto dominio della valutazione, quello economico, e ne costituisce il cuore quantitativo. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i valori, ancorati alla Sardegna. La parte definisce l'impianto e il costo del servizio (capitolo E.1); quantifica i risparmi diretti per il bilancio sanitario, canale per canale (E.2); stima le ricadute economico-sociali per la collettività (E.3); compone il quadro consolidato, con il saldo e il rapporto beneficio-costi, tenendo ferma la distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico (E.4); presenta l'analisi costo-utilità per paziente e la sua robustezza probabilistica (E.5); e valuta l'impatto sul bilancio e la sostenibilità (E.6). Per la Sardegna il risultato si lascia anticipare in una formula: il caso finanziario diretto è di modesto disavanzo prossimo al pareggio, il caso economico complessivo è fortemente positivo, e il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali.

E.1 L'impianto e il costo del servizio

La valutazione economica impiega congiuntamente tre strumenti complementari — l'analisi costo-utilità, l'analisi di impatto sul bilancio e l'analisi del ritorno sociale — nella doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, che distingue i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute più ampie.^[2458] Il costo del servizio a regime, assumendo un costo medio annuo per psicologo dell'ordine di 55.000 euro comprensivo degli oneri — riferimento prudenziale, dato che il modello dipartimentale a dipendenza può implicare un costo unitario superiore — è dell'ordine di 9 milioni di euro nello scenario conservativo, 14 milioni in quello di base e 19 milioni in quello espansivo.^[2459] I tre scenari rappresentano gradi crescenti di copertura verso il fabbisogno pieno; va ribadito che il Dipartimento attualmente attivo nella sola Azienda di Sassari costituisce un'attuazione iniziale inferiore allo stesso scenario conservativo, e non il regime qui considerato.^[2460] La tabella seguente riepiloga il costo del servizio per scenario.

Scenario	Psicologi	Costo annuo	Quota del FSR
Conservativo	~ 170	~ 9 milioni	~ 0,3%
Base	~ 250	~ 14 milioni	~ 0,4%
Espansivo	~ 340	~ 19 milioni	~ 0,5%

Tabella E.1. Il costo del servizio a regime nei tre scenari di copertura.

E.2 I risparmi diretti per il bilancio sanitario

I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale si articolano in quattro canali. Il primo è la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, dell'ordine di 1, 2 e 3 milioni di euro l'anno nei tre scenari.^[2461] Il secondo è la riduzione della spesa farmaceutica inappropriata, dell'ordine di 1, 2 e 3 milioni, con margine significativo data una spesa farmaceutica regionale sopra la media nazionale.^[2462] Il terzo, il più consistente, è la riduzione di ricoveri evitabili e di specialistica impropria, dell'ordine di 4, 6 e 10 milioni, con un margine di recupero ampio data la sotto-dotazione storica del sistema e la cronicità di una popolazione anziana.^[2463] Il quarto, il recupero della mobilità, è per la Sardegna modesto, dell'ordine di 1, 2 e 3 milioni: benché la regione presenti un rilevante saldo passivo, la fuga riguarda le terapie oncologiche e l'alta complessità, per necessità, non la domanda psicologica, sicché questo canale contribuisce solo per la quota di domanda impropria, prevalentemente somatoforme, territorialmente intercettabile.^[2464] La somma dei quattro canali è dell'ordine di 7, 12 e 19 milioni di euro l'anno, e determina, a fronte del costo del servizio, un saldo diretto lievemente negativo ma prossimo al pareggio, dell'ordine di -2, -2 e 0 milioni.^[2465] La tabella seguente dettaglia i canali del risparmio diretto.

Canale (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Accessi impropri al pronto soccorso	~ 1	~ 2	~ 3
Spesa farmaceutica inappropriata	~ 1	~ 2	~ 3
Ricoveri evitabili e specialistica	~ 4	~ 6	~ 10
Recupero della mobilità (frazione territoriale)	~ 1	~ 2	~ 3
Totale risparmi diretti	~ 7	~ 12	~ 19
Costo del servizio	~ 9	~ 14	~ 19
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -2	~ -2	~ 0

Tabella E.2. I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale e il saldo diretto.

E.3 Le ricadute economico-sociali

Oltre i confini del bilancio sanitario, l'intervento genera ricadute economico-sociali ampie, di cui la valutazione tiene conto nella prospettiva societale. Esse comprendono il recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo — concentrato nei poli urbani e nella componente giovanile — e, con peso particolare in una delle regioni più anziane d'Italia, il valore del benessere recuperato e il minor carico assistenziale sulle famiglie nelle aree interne segnate da cronicità e solitudine, e sono stimate, secondo i criteri prudenziali dello studio, nell'ordine di 30, 56 e 85 milioni di euro l'anno nei tre scenari.^[2466] Sommate ai risparmi diretti, esse determinano un ritorno complessivo dell'ordine di 37, 68 e 104 milioni di euro l'anno, e un saldo complessivo per la collettività ampiamente positivo, dell'ordine di +28, +54 e +85 milioni.^[2467] Ne discende un rapporto beneficio-costo complessivo dell'ordine di 4,1 a uno nello scenario conservativo, 4,9 a uno in quello di base e 5,5 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale adottata.^[2468]

E.4 Il quadro consolidato: caso finanziario e caso economico

La composizione delle grandezze impone di tenere ferma una distinzione che governa l'intera lettura del caso sardo. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, prossimo al pareggio, poiché i risparmi diretti quasi coprono il costo del servizio e il canale della mobilità è modesto. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe: si tratta di un investimento sociale, a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto molto contenuto per il bilancio sanitario e senza ticket a carico del paziente.^[2469] La tabella consolidata che segue è lo strumento sintetico per la decisione, e distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale.^[2470]

Voce (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 9	~ 14	~ 19
Risparmi diretti (SSR)	~ 7	~ 12	~ 19
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -2	~ -2	~ 0
Ricadute economico-sociali	~ 30	~ 56	~ 85
Ritorno complessivo	~ 37	~ 68	~ 104
Saldo complessivo (caso economico)	~ +28	~ +54	~ +85
Rapporto beneficio-costo complessivo	~ 4,1:1	~ 4,9:1	~ 5,5:1

Tabella E.3. Il quadro economico consolidato, con la distinzione fra caso finanziario e caso economico.

E.5 L'analisi costo-utilità per paziente

Accanto alle grandezze aggregate, la valutazione conduce un'analisi costo-utilità per paziente trattato, mediante un modello di Markov a cinque anni con sconto del 3%, indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. Il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: a un tempo meno costoso e più efficace.

[2471] L'analisi di sensibilità probabilistica, su diecimila simulazioni, conferma la solidità del risultato: l'intervento è costo-efficace nell'88,9% dei casi alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro.

[2472] La tabella seguente riepiloga il risultato per paziente.

Grandezza (per paziente)	Comparatore	Intervento	Differenza
Costo atteso per paziente	~ 3.799 euro	~ 2.495 euro	- 1.304 euro
Anni di vita ponderati (QALY)	3,392	3,627	+ 0,236
Esito	—	—	Intervento dominante
Costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	—	—	88,9% delle simulazioni

Tabella E.4. L'analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni).

E.6 L'impatto sul bilancio, la sostenibilità e la lacuna dei dati

Sul piano dell'impatto sul bilancio, il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta del finanziamento sanitario regionale, dell'ordine dello 0,3% nello scenario conservativo e dello 0,5% in quello espansivo; la sostenibilità è condizionata dal fatto che la Sardegna, regione a statuto speciale, si autofinanzia integralmente la sanità — sicché i tetti nazionali di spesa non le si applicano, purché rispetti il pareggio — ma registra il più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale, sicché il vincolo di bilancio è severo, pur a fronte di un sistema sotto-finanziato con ampio margine di recupero; il modello dipartimentale è inoltre gratuito. La strutturazione a regime richiede la copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione del Dipartimento. [2473] Resta da dichiarare con franchezza la lacuna dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti certificati delle Aziende; poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, la Sardegna dispone di una base di dati operativi propri limitata, sicché la stima poggia sui benchmark, e il monitoraggio del Dipartimento ne sarà la fonte primaria; l'estrazione dei dati certificati resta la priorità da completare. [2474] La sintesi è univoca: il caso diretto è prudente e prossimo al pareggio, il caso sociale è robusto e fortemente positivo, il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità, in piena coerenza con la cautela metodologica già enunciata, per cui il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali e non in un risparmio di bilancio che lo studio si astiene dal rivendicare. [2475] La parte che segue sottopone questo quadro alla prova dell'incertezza e della modellazione.

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte completa il dominio economico sottoponendo i risultati della Parte E alla prova della modellazione e dell'incertezza. Come per le altre regioni, il modello è invariante e muta solo ciò che attiene alla verifica empirica locale. La parte descrive il modello decisionale e i suoi parametri (capitolo F.1); ne saggia la

robustezza con l’analisi di sensibilità deterministica (F.2) e probabilistica (F.3); ne esplora gli scenari di copertura (F.4); e definisce il disegno della verifica empirica e il valore dell’informazione (F.5). Per la Sardegna quest’ultimo capitolo riveste un’importanza particolare: poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, la prova empirica si ancora inizialmente ai benchmark, ma l’attivazione scaglionata del Dipartimento nelle otto Aziende offre l’opportunità di impostare fin dall’inizio una rilevazione uniforme, avvalendosi del coordinamento dell’ARES, presupposto di un’evidenza locale solida.

F.1 Il modello decisionale e i suoi parametri

Poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l’orizzonte direttamente osservabile, lo studio li proietta nel tempo mediante un modello decisionale, e ne rende esplicite le assunzioni.^[2476] La storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%.^[2477] A ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita, trattati come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l’incertezza.^[2478] Nel caso base l’intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell’ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità.^[2479] La tabella seguente riepiloga i parametri principali del modello.

Parametro del modello	Valore
Stati clinici	Benessere o sottosoglia, episodio, cronicità, recupero
Orizzonte temporale	Cinque anni, con cicli successivi
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti
Costo per ciclo (recupero)	~ 40 euro
Costo per ciclo (cronicità)	~ 700 euro
Costo dell’intervento	~ 300 euro una tantum
Trattamento dell’incertezza	Parametri come distribuzioni di probabilità

Tabella F.1. I parametri principali del modello di Markov (comune a tutti gli studi della serie).

F.2 L’analisi di sensibilità deterministica

La robustezza del risultato è saggiata, in prima istanza, variando un parametro per volta entro intervalli plausibili. La variazione dei parametri più influenti — l’efficacia dell’intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — non muta il segno del risultato, che resta favorevole all’intervento in tutti i casi esaminati.^[2480] L’ordinamento dei parametri per influenza mostra che l’esito è più sensibile all’efficacia clinica e al costo evitato della cronicità, e meno agli altri parametri; ciò orienta le priorità di raccolta dei dati verso le grandezze più influenti.^[2481]

F.3 L'analisi di sensibilità probabilistica

In seconda istanza, la robustezza è saggiata facendo variare simultaneamente tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni, su diecimila simulazioni. L'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro.^[2482] La curva di accettabilità conferma che alla soglia convenzionale la probabilità di convenienza è prossima al 90% e cresce per soglie superiori, mantenendosi elevata anche a soglie molto inferiori.^[2483] La tabella seguente riepiloga gli esiti della sensibilità probabilistica.

Esito della sensibilità probabilistica	Valore
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	88,9% delle simulazioni
Probabilità di dominanza	84,6% delle simulazioni
Beneficio monetario netto medio per paziente	~ 7.815 euro
Intervallo di confidenza al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 euro
Numero di simulazioni	10.000

Tabella F.2. Gli esiti dell'analisi di sensibilità probabilistica (per paziente).

F.4 Gli scenari di copertura e l'incertezza aggregata

Gli scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; la dotazione delle proposte di legge in itinere corrisponde a un punto d'ingresso iniziale inferiore allo scenario conservativo, prima tappa di un percorso di estensione progressiva.^[2484] È in questa sede che va ribadita una distinzione di onestà analitica: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema.^[2485]

F.5 La verifica empirica e il valore dell'informazione

Il disegno della verifica empirica costituisce, per la Sardegna, un capitolo da impostare con cura. Poiché il Dipartimento è attivo nella sola Azienda di Sassari e la sua estensione alle altre avverrà in tempi differenziati, la verifica controfattuale può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione del Dipartimento tra le otto Aziende socio-sanitarie locali sono impiegati a fini valutativi: l'attuazione iniziale consente di rilevare una linea di base prima della piena operatività e l'attivazione scaglionata, a partire da Sassari, fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto.^[2486] L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il controllo sintetico, a partire dai dati che affluiscono man mano che il Dipartimento si attiva e dalla progressione differenziata della sua estensione fra le Aziende.^[2487] L'analisi del valore dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione sarda, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle Aziende e l'impostazione di un flusso uniforme dei dati di esito attraverso il monitoraggio del

Dipartimento.^[2488] L’attuazione iniziale consente così di impostare correttamente la rilevazione fin dall’inizio, conducendo la regione, in modo programmato, da una valutazione fondata su dati esterni a una fondata in misura crescente su dati propri.^[2489] La sintesi è univoca: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l’incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione e consolidamento dei dati, e la condizione di regione ad attuazione parziale impone di ancorare inizialmente la prova ai benchmark, valorizzando l’opportunità di una rilevazione ben progettata. La parte che segue affronta l’equità e l’impatto distributivo.^[2490]

Priorità di ricerca	Finalità	Rilevanza
Conti certificati delle otto Aziende e delle AOU	Sostituire le stime per quota con dati reali	Massima
Consolidamento dei dati di esito del Dipartimento attivo	Uniformare e completare l’evidenza propria	Massima
Tassi di intercettazione e costi evitati	Ridurre l’incertezza sulle grandezze aggregate	Alta
Efficacia clinica nel contesto locale	Corroborare il parametro più influente	Alta

Tabella F.3. Le priorità di ricerca derivanti dall’*****analisi del valore dell’*****informazione.

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte affronta il dominio dell’equità, che la valutazione di tecnologia sanitaria tiene distinto dall’efficienza. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano i dati distributivi, ancorati alla Sardegna. La parte definisce il quadro dell’equità e il gradiente sociale (capitolo G.1); analizza i due assi territoriali del divario sardo e le barriere di accesso (G.2); descrive gli strumenti attraverso cui il servizio agisce sull’equità (G.3); e presenta l’analisi di costo-efficacia distributiva con le sue implicazioni allocative (G.4). Il tratto distintivo della Sardegna è la doppia struttura del divario territoriale — poli urbani contro aree interne spopolate e fra le più anziane d’Italia, e centro e periferia entro i poli di Sassari e Cagliari — e, sul piano dello strumento, la gratuità del modello dipartimentale, che rimuove ogni barriera economica; l’intervento può ridurre tali divari, a condizione di un’allocazione modulata per il bisogno.

G.1 Il quadro dell’equità e il gradiente sociale

L’analisi distributiva costituisce un dominio proprio della valutazione, poiché un intervento efficiente nel complesso può nondimeno accrescere o ridurre le disuguaglianze; lo studio ne misura l’effetto con l’analisi di costo-efficacia distributiva.^[2491] Il punto di partenza è il gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori.^[2492] A questo gradiente si sommano barriere di accesso economiche, geografiche e culturali, oltre allo stigma; nella Sardegna, dove la componente straniera è fra le più basse del Paese, più rilevanti della barriera culturale sono quella geografica delle aree interne spopolate e quella generazionale, mentre — tratto proprio e favorevole del modello regionale — la gratuità del Dipartimento rimuove la barriera economica che un ticket comporterebbe.^[2493]

G.2 I due assi del divario territoriale

La specificità distributiva della Sardegna risiede nella doppia struttura del divario territoriale, cui si aggiunge la dimensione generazionale.^[2494] Il primo asse, il più caratterizzante, separa i poli urbani dalle aree interne: Oristano, Nuoro e il Sud Sardegna, e in generale le aree interne dell'Isola, presentano una popolazione fra le più anziane d'Italia, a bassissima densità e in forte spopolamento, dove la rarefazione dei servizi, le distanze e la condizione insulare rendono l'accesso particolarmente difficoltoso, mentre la cronicità e la solitudine ne accrescono il bisogno.^[2495] Il secondo asse è interno ai poli urbani di Sassari e Cagliari: accanto a quartieri meglio serviti si estendono periferie con sacche di deprivazione socio-economica, dove la difficoltà di accesso e la minore disponibilità di offerta privata accrescono il bisogno non intercettato, in particolare giovanile.^[2496] La tabella seguente sintetizza i due assi e le leve di riequilibrio.

Asse del divario	Caratterizzazione	Leva di riequilibrio
Poli urbani / aree interne spopolate	Oristano, Nuoro, Sud Sardegna: popolazione fra le più anziane, bassissima densità, spopolamento, condizione insulare	Telepsicologia assistita; presenza programmata di primo livello
Centro / periferia dei poli urbani	Periferie di Sassari e Cagliari con sacche di deprivazione e minore offerta privata	Sedi nelle Case della Comunità di periferia; allocazione pro-equità
Età anziana, cronicità e disagio giovanile	Bisogno anziano prevalente nelle aree interne; disagio giovanile nei poli	Competenza per l'età anziana e la cronicità; intercettazione del disagio giovanile

Tabella G.1. I due assi del divario territoriale sardo, la dimensione generazionale e le leve di riequilibrio.

G.3 Gli strumenti dell'equità

Il servizio agisce sull'equità attraverso meccanismi precisi. La prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano parte delle barriere e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso; nel modello sardo, integralmente gratuito, il pieno effetto pro-equità opera senza l'attenuazione che un ticket comporterebbe, poiché nessuna compartecipazione si frappone all'accesso delle fasce a minore capacità di spesa.^[2497] La telepsicologia assistita avvicina l'offerta alle aree interne e spopolate di Oristano, Nuoro e del Sud Sardegna e alle periferie dei poli urbani, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, estendendo la copertura proprio dove l'accesso è più difficile.^[2498] La competenza nell'accompagnare l'età anziana e la cronicità è dirimente in una popolazione fra le più anziane d'Italia, mentre quella nell'intercettare il disagio giovanile assicura che il servizio raggiunga adolescenti e giovani adulti dei poli urbani; la competenza culturale, data la quota straniera fra le più basse del Paese, è meno centrale che altrove.^[2499]

G.4 La costo-efficacia distributiva e le implicazioni allocative

L'analisi di costo-efficacia distributiva indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, poiché i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto.^[2500] Perché questo potenziale si realizzi, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle aree interne spopolate e alle periferie dei poli urbani: un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un'allocazione ponderata

per il bisogno li riduce.^[2501] Va inoltre tenuto presente che, nella Sardegna, il canale della mobilità costituisce una leva di equità solo modesta per questo intervento, sicché l’equità si gioca prevalentemente sull’accesso interno; mentre la gratuità del modello dipartimentale rappresenta, sul piano dell’equità, un vantaggio strutturale, poiché nessun ticket grava sulle fasce a minore capacità di spesa.^[2502] Esiste infine un rischio di iniquità inversa: se l’estensione del Dipartimento privilegiasse, per facilità organizzativa, le aree già meglio servite — a partire dai poli urbani, già da Sassari — l’effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell’allocazione, fin dall’estensione del Dipartimento alle Aziende che servono le aree interne.^[2503] La sintesi è che l’intervento è favorevole all’equità su entrambi gli assi e sulla dimensione generazionale, e che la gratuità del modello ne rafforza la natura pro-equità; a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno e che siano garantite la telepsicologia per le aree interne spopolate e l’attenzione congiunta all’età anziana e al disagio giovanile, la raccomandazione è di orientare fin dall’estensione del Dipartimento un’allocazione pro-equità che dia di più dove il bisogno è maggiore, segnatamente nelle aree interne.^[2504] La tabella seguente riepiloga l’impatto distributivo atteso.

Dimensione distributiva	Esito per la Sardegna
Efficienza complessiva	Intervento costo-efficace e dominante per paziente
Direzione dell’effetto distributivo	Favorevole all’equità: maggiori benefici nei gruppi a più alto bisogno
Condizione di realizzazione	Allocazione modulata per il bisogno (aree interne spopolate e periferie dei poli)
Strumenti abilitanti	Prossimità, gratuità del modello, telepsicologia, competenza per l’età anziana e giovanile
Rischio da prevenire	Iniquità inversa se l’estensione del Dipartimento privilegia i poli urbani

Tabella G.2. L ‘*******impatto distributivo atteso dell’*******’intervento e le sue condizioni.

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte affronta congiuntamente i domini giuridico, organizzativo ed etico, che la valutazione tiene distinti ma interdipendenti. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati alla Sardegna. La parte tratta il profilo giuridico — la competenza, la forma dell’atto, il rapporto di lavoro e i livelli essenziali (capitolo H.1); il profilo organizzativo — l’assetto e la governance del servizio (H.2); il profilo etico — le tutele a garanzia dei pazienti (H.3); e la sintesi dei tre profili (H.4). Il tratto distintivo della Sardegna emerge sul piano giuridico: a differenza del Lazio, ancora privo di legge, la regione dispone già di una previsione di legge che istituisce in via sperimentale un Dipartimento a modello dipartimentale, attivato però nella sola Azienda di Sassari, sicché la condizione abilitante non è l’approvazione della legge, ma la piena attivazione, l’estensione alle otto Aziende e l’adozione del provvedimento di copertura finanziaria cui la legge la subordina.

H.1 Il profilo giuridico

La fattibilità dell’intervento dipende dal presidio congiunto dei tre profili, una debolezza in uno solo dei quali ne comprometterebbe l’esito.^[2505] Sul piano giuridico, la materia si colloca nella competenza concorrente in tema di tutela della salute, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — originata dal giudizio

sulla legge campana, di cui ha riconosciuto la legittimità — ne ha delimitato lo spazio regionale: entro questa cornice la Sardegna, regione a statuto speciale, ha esercitato il titolo a prevedere il servizio con la legge regionale 24 del 2020 di riforma sanitaria.^[2506] Qui si colloca la specificità della regione: disponendo già della legge regionale 24 del 2020 (articolo 37) e della deliberazione di Giunta 9/22 del 2022, la decisione giuridica rilevante non è l’approvazione della norma, già compiuta, ma la piena attivazione del Dipartimento e la sua estensione alle otto Aziende.^[2507] Il rapporto di lavoro adottato è quello di dipendenza, nell’ambito di Strutture Complesse di Psicologia territoriale di base interne a ciascuna Azienda, senza ticket a carico del paziente: una forma che assicura stabilità e integrazione, ma comporta un costo unitario potenzialmente superiore al convenzionale.^[2508] Quanto ai livelli essenziali di assistenza, la psicologia delle cure primarie non vi è ancora esplicitamente ricompresa, e il servizio, sostenuto entro i vincoli dello statuto speciale autofinanziante, richiede l’adozione del provvedimento di copertura finanziaria cui la legge subordina l’attivazione del Dipartimento.^[2509] Il servizio si inserisce coerentemente nella cornice degli standard territoriali e delle Case della Comunità,^[2510] e si rapporta ai Centri di Salute Mentale per integrazione e non per sovrapposizione, precedendoli e alleggerendoli.^[2511] La tabella seguente riepiloga i profili giuridici.

Profilo giuridico	Contenuto per la Sardegna
Competenza	Concorrente in tutela della salute; Corte Cost. 241/2021 (originata dalla legge campana) ha delimitato lo spazio regionale
Forma dell’atto	Legge regionale 24/2020 (art. 37) di riforma e Delibera di Giunta 9/22 del 2022; Dipartimento sperimentale, da attivare pienamente
Rapporto di lavoro	Dipendenza in Strutture Complesse interne alle Aziende, senza ticket; costo unitario potenzialmente superiore al convenzionale
Livelli essenziali di assistenza	Non ancora ricompresi; statuto speciale autofinanziante (tetti non applicabili); attivazione subordinata a copertura finanziaria
Cornice territoriale	Decreto Ministeriale 77/2022; inserimento nelle Case della Comunità
Rapporto con i servizi specialistici	Integrazione con i Centri di Salute Mentale, che il servizio precede e alleggerisce

Tabella H.1. I profili giuridici del servizio nella Sardegna.

H.2 Il profilo organizzativo e la governance

Sul piano organizzativo, la strutturazione del servizio nella Sardegna si misura con un sistema insulare a bassa densità — otto Aziende socio-sanitarie locali, aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie — ma, a differenza della Sicilia, dispone di un’azienda regionale di coordinamento, l’ARES, sicché la sfida centrale è garantire l’estensione omogenea del Dipartimento alle otto Aziende, agevolata dal coordinamento dell’ARES.^[2512] Il consolidamento poggia su una regia regionale che coordina le Aziende, l’ARES, l’Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei di Cagliari e Sassari, cui spetta definire indirizzi operativi uniformi e impostare il sistema di monitoraggio comune del Dipartimento, traendo dall’esperienza dell’Azienda di Sassari un primo modello.^[2513] In questo quadro l’Ordine delle

Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna, che ha sollecitato l’inserimento del Dipartimento nella legge di riforma, concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione e alla vigilanza deontologica.^[2514] La tabella seguente sintetizza l’assetto organizzativo e di governance.

Elemento organizzativo	Assetto per la Sardegna
Articolazione del sistema	Otto Aziende socio-sanitarie locali; Azienda regionale della salute (ARES); aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie
Coordinamento	Azienda regionale della salute (ARES) e Assessorato regionale dell’igiene e sanità; presenza di un’azienda regionale di coordinamento
Sfida organizzativa	Estensione omogenea del Dipartimento alle otto Aziende in un sistema insulare a bassa densità
Regia della strutturazione	Indirizzi operativi uniformi e monitoraggio comune in capo all’ARES e all’Assessorato
Soggetti coinvolti	Aziende, Ordine professionale, medicina generale e pediatria, atenei

Tabella H.2. L ‘*****assetto organizzativo e la governance dell*****’istituzione.

H.3 Il profilo etico

Sul piano etico, lo studio adotta cautele a tutela dei pazienti. Le situazioni che coinvolgono minori e persone vulnerabili sono presidiate impiegando gli strumenti di esito nei soli punteggi complessivi e indirizzando le situazioni di rischio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza entrare nel merito dei metodi clinici.^[2515] L’intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un’informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell’efficacia stessa del sostegno.^[2516] Gli strumenti di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, in conformità al quadro europeo e ai requisiti sui dispositivi medici,^[2517] il trattamento dei dati è conforme alla normativa e ispirato alla minimizzazione,^[2518] e la responsabilità delle decisioni cliniche resta interamente in capo al professionista, cui gli strumenti forniscono un ausilio non vincolante.^[2519]

H.4 Sintesi dei profili

La ricognizione dei tre profili conduce a una conclusione netta: il profilo giuridico, quello organizzativo e quello etico sono tutti presidiati, e la condizione abilitante dell’intervento non è, per la Sardegna, l’approvazione della legge — già in vigore — ma la piena attivazione del Dipartimento, la sua estensione alle otto Aziende e l’adozione del provvedimento di copertura finanziaria cui la legge la subordina, entro il vincolo del pareggio di bilancio proprio dello statuto speciale. È questo il passaggio da cui dipende la piena operatività del servizio.^[2520] Definiti i profili, la parte che segue affronta l’attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte affronta l’attuazione, la fattibilità e la sostenibilità dell’intervento, organizzandole secondo il modello a cinque casi della decisione di investimento pubblico. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto, ancorati alla Sardegna. La parte espone i cinque casi (capitolo I.1);

definisce il dimensionamento a partire dall’attuazione parziale e le fasi di attuazione (I.2); tratta il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma (I.3); analizza la sostenibilità finanziaria e organizzativa (I.4); e individua i rischi e le mitigazioni (I.5). Il tratto distintivo della Sardegna è che l’attuazione muove da un Dipartimento già previsto per legge e attivato nella sola Azienda di Sassari: non l’istituzione, ma la piena attivazione e il passaggio a regime, condizionati non dall’approvazione di una legge — già in vigore — ma dall’adozione del provvedimento di copertura finanziaria cui la legge la subordina e dall’estensione del Dipartimento alle otto Aziende, entro il vincolo del pareggio di bilancio.

I.1 I cinque casi della decisione

Lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile.^[2521] Il caso strategico è solido: l’istituzione del servizio è coerente con gli standard territoriali, con le Case della Comunità e con il Piano regionale di salute mentale, e nella Sardegna porta a regime il modello dipartimentale che la regione ha già previsto per legge e istituito in via sperimentale.^[2522] Il caso economico rinvia ai risultati già esposti, nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di modesto disavanzo e un caso sociale fortemente positivo.^[2523] Il caso commerciale è già disciplinato e si avvale di un bacino professionale alimentato dagli atenei sardi di Cagliari e Sassari, con psicologi da inquadrare a dipendenza nelle Strutture Complesse di Psicologia territoriale di base.^[2524] Il caso finanziario presenta un costo contenuto, pari allo 0,3-0,5% del finanziamento sanitario regionale, da reperire però entro il vincolo del pareggio di bilancio proprio dello statuto speciale, mediante il provvedimento di copertura finanziaria cui la legge subordina l’attivazione.^[2525] Il caso gestionale dipende da una regia regionale che, avvalendosi dell’azienda regionale di coordinamento (ARES), coordini il sistema insulare delle otto Aziende.^[2526] La tabella seguente riepiloga i cinque casi.

Caso	Contenuto per la Sardegna
Strategico	Coerenza con DM 77/2022, Case della Comunità e programmazione salute mentale; passaggio a regime del modello dipartimentale già previsto per legge
Economico	Rapporto beneficio-costi 4,1-5,5 a uno; dominanza per paziente; caso sociale fortemente positivo
Commerciale	Modello a dipendenza già disciplinato; bacino dagli atenei sardi (Cagliari, Sassari); inquadramento nelle Strutture Complesse delle Aziende
Finanziario	Costo 0,3-0,5% del FSR; statuto speciale autofinanziante (pareggio di bilancio); attivazione subordinata a copertura finanziaria
Gestionale	Regia regionale avvalendosi dell’ARES per il coordinamento del sistema insulare delle otto Aziende

Tabella I.1. I cinque casi della decisione di investimento pubblico.

I.2 Il dimensionamento dal nucleo di avvio e le fasi di attuazione

A differenza del Lazio, che dimensiona il servizio da zero, la Sardegna muove dal Dipartimento già attivato nella sola Azienda di Sassari e lo estende verso un fabbisogno a regime dell’ordine di 340 psicologi nello scenario espansivo; l’estensione procede per gradi attraverso gli scenari conservativo, di base ed espansivo.^[2527] L’attuazione si articola perciò in tre fasi: una fase di attivazione, con l’adozione della copertura

finanziaria e l'avvio operativo; una fase di estensione, nella quale il Dipartimento si attiva progressivamente nelle otto Aziende; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato. La progressione differenziata dell'attivazione fra le Aziende, a partire da Sassari, coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F.^[2528] La tabella seguente riepiloga le fasi.

Fase	Contenuto	Dimensionamento indicativo
Attivazione	Provvedimento di copertura finanziaria e avvio operativo	Dipartimento attivo a Sassari
Estensione	Attivazione progressiva del Dipartimento nelle otto Aziende	verso ~ 170-250 psicologi
Regime	Dimensionamento adeguato al fabbisogno	fino a ~ 340 psicologi

Tabella I.2. Le fasi di attuazione e il dimensionamento progressivo.

I.3 Reclutamento, formazione e cronoprogramma

L'estensione richiede il reclutamento a dipendenza e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino professionale e gli atenei sardi di Cagliari e Sassari costituiscono una base favorevole, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze, con particolare attenzione all'età anziana e alla cronicità.^[2529] Il cronoprogramma si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; a differenza del Lazio, l'estensione non è subordinata all'approvazione di una legge — già in vigore — ma all'adozione del provvedimento di copertura finanziaria cui la legge la subordina e all'estensione del Dipartimento alle otto Aziende, entro il vincolo del pareggio di bilancio.^[2530]

I.4 La sostenibilità finanziaria e organizzativa

La sostenibilità finanziaria, nella Sardegna, ha per leva l'adozione del provvedimento di copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione, entro il vincolo del pareggio di bilancio proprio dello statuto speciale, e il dimensionamento progressivo del servizio; il sistema, storicamente sotto-finanziato e gravato dal più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale, presenta margini di consumo improprio ampi da recuperare, mentre l'eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe in futuro la stabilità.^[2531] La sostenibilità organizzativa dipende invece dalla capacità di garantire l'estensione omogenea del Dipartimento alle otto Aziende socio-sanitarie locali in un sistema insulare a bassa densità, agevolata dalla presenza dell'azienda regionale di coordinamento (ARES) e dalla chiarezza degli indirizzi operativi.^[2532] L'avanzamento è seguito mediante indicatori di processo raccolti attraverso il monitoraggio del Dipartimento, che l'attuazione parziale consente di impostare fin dall'inizio in forma uniforme fra le otto Aziende.^[2533]

I.5 I rischi e le mitigazioni

L'attuazione presenta rischi propri della posizione sarda: la disomogeneità attuativa fra le otto Aziende in un sistema insulare a bassa densità, il vincolo del pareggio di bilancio e del disavanzo strutturale sulla disponibilità della copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione, il maggior costo unitario del modello a dipendenza e il rischio che l'estensione privilegi i poli urbani a scapito delle aree interne.^[2534] Tali rischi sono fronteggiati con la regia dell'ARES e indirizzi operativi uniformi, con la progressione differenziata dell'attivazione del Dipartimento che consente un apprendimento progressivo a partire da Sassari, e con un'allocazione pro-equità che orienta l'estensione verso le aree interne a maggiore bisogno; l'adozione della

copertura finanziaria e il sostegno dell’Ordine professionale concorrono a ridurre l’incertezza.^[2535] La sintesi è che l’intervento è attuabile e sostenibile, e che la leva propria della Sardegna è l’adozione della copertura finanziaria cui la legge subordina l’attivazione e l’estensione del Dipartimento alle otto Aziende: la regione muove da un Dipartimento già attivato a Sassari, da un bacino professionale adeguato, da una previsione normativa acquisita e dal coordinamento dell’ARES, sicché le condizioni di fattibilità sono complessivamente favorevoli, pur entro un vincolo di bilancio severo.^[2536] La tabella seguente riepiloga i rischi e le relative mitigazioni; la parte che segue affronta il monitoraggio e la valutazione ex post.

Rischio	Mitigazione
Disomogeneità attuativa fra le otto Aziende	Regia dell’ARES; indirizzi operativi uniformi; monitoraggio comune
Maggior costo unitario del modello a dipendenza	Dimensionamento prudenziale; copertura finanziaria adeguata; recupero del consumo improprio
Vincolo del pareggio di bilancio e disavanzo strutturale	Copertura finanziaria cui la legge subordina l’attivazione; disegno per fasi; sostegno dell’Ordine
Allocazione non equa nell’estensione (rischio poli urbani)	Criteri di equità espliciti; estensione pro-equità verso le aree interne spopolate; gratuità del modello

Tabella I.3. I rischi dell’attuazione e le relative mitigazioni.

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Questa parte definisce il sistema di monitoraggio e la valutazione ex post dell’intervento, attraverso cui l’istituzione del servizio si traduce in apprendimento e rendicontazione. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e muta ciò che attiene al disegno valutativo locale. La parte espone le finalità e l’impianto della valutazione (capitolo L.1); il disegno controfattuale e i metodi di stima (L.2); la batteria degli indicatori, organizzata per categorie (L.3); il cruscotto regionale e la clausola valutativa (L.4); e la sintesi (L.5). Il tratto distintivo della Sardegna è che, essendo il Dipartimento attivo nella sola Azienda di Sassari, la valutazione può disporre di una linea di base nelle Aziende non ancora dotate, e la clausola valutativa — da corredare all’attivazione del Dipartimento istituito in via sperimentale — va costruita avvalendosi del monitoraggio coordinato dall’ARES.

L.1 Finalità e impianto della valutazione

Il monitoraggio e la valutazione ex post servono a rendere conto dell’impiego delle risorse, ad apprendere dall’esperienza e a correggere il corso dell’attuazione; non sono un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l’istituzione del servizio diventa apprendimento istituzionale, ancorato a una clausola valutativa.^[2537] L’impianto distingue i tre livelli della struttura, del processo e dell’esito, in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti.^[2538]

L.2 Il disegno controfattuale e i metodi

Il disegno della valutazione d'impatto costituisce, per la Sardegna, un punto di forza dello studio. Poiché il Dipartimento è attivo nella sola Azienda di Sassari e la sua estensione alle altre avverrà in tempi differenziati, la valutazione può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione del Dipartimento tra le otto Aziende socio-sanitarie locali sono impiegati a fini valutativi.^[2539] A differenza delle regioni a servizio già consolidato, la Sardegna può rilevare una linea di base nelle Aziende non ancora dotate, e il diverso grado di attivazione del Dipartimento fra le Aziende consente di costruire termini di confronto interni, fondando la stima su dati propri progettati fin dall'inizio.^[2540] L'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, con la progressione differenziata dell'attivazione del Dipartimento a fornire la variazione necessaria all'identificazione.^[2541]

L.3 La batteria degli indicatori

Il servizio è osservato attraverso una batteria di indicatori organizzata per categorie. Gli indicatori di struttura misurano la capacità installata — sedi, incarichi, ore, dotazione, copertura.^[2542] Gli indicatori di processo misurano il funzionamento — prese in carico, attesa, colloqui, invio appropriato.^[2543] Gli indicatori di esito clinico misurano il beneficio diretto — miglioramento, recupero, remissione.^[2544] Gli indicatori di esito di sistema misurano l'effetto sul resto del sistema — pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri.^[2545] Gli indicatori economici consentono di verificare ex post le stime e di sostituire i valori ricostruiti con quelli effettivi.^[2546] Gli indicatori di equità, disaggregati per area e per fasce di età, verificano che il servizio riduca i divari fra poli urbani e aree interne spopolate e fra centro e periferie dei poli, con attenzione congiunta all'età anziana, alla cronicità e al disagio giovanile, e all'effettiva accessibilità garantita dalla gratuità del modello.^[2547] Gli indicatori di qualità integrano la misurazione con la dimensione dell'esperienza.^[2548] Gli indicatori di mobilità, infine, sono monitorati ma costituiscono un esito atteso solo modesto, limitato alla frazione territorialmente intercettabile.^[2549] L'insieme conta dell'ordine di cinquantotto indicatori in otto categorie, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile.^[2550] La tabella seguente riepiloga le categorie.

Categoria	Contenuto (dell'ordine di 58 indicatori complessivi)
Struttura	Sedi attivate, incarichi, ore, dotazione, copertura del fabbisogno
Processo	Prese in carico, attesa al primo colloquio, colloqui per persona, invio appropriato
Esito clinico	Miglioramento, recupero, remissione (strumenti validati, punteggi complessivi)
Esito di sistema	Accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili, specialistica impropria
Economici	Costo, risparmi diretti, ricadute sociali, rapporto beneficio-costi su dati reali
Equità	Copertura e accesso per area (poli urbani, periferie, aree interne spopolate) e per fasce di età; accessibilità garantita dalla gratuità
Qualità	Soddisfazione, appropriatezza, continuità del rapporto
Mobilità	Monitorata; esito atteso modesto (sola frazione territorialmente intercettabile)

Tabella L.1. Le otto categorie della batteria di indicatori.

L.4 Il cruscotto regionale e la clausola valutativa

Gli indicatori confluiscono in un cruscotto regionale aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; la titolarità del cruscotto è in capo all'Azienda regionale della salute (ARES) e all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, che ne assicurano l'alimentazione uniforme da parte delle otto Aziende.^[2551] Lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa; poiché la legge regionale 24 del 2020 ha istituito il Dipartimento in via sperimentale, il compito è correderne l'attivazione di una clausola valutativa che impegni la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale.^[2552] La raccolta dei dati poggia sul monitoraggio del Dipartimento coordinato dall'ARES, da impostare fin dall'attivazione in forma uniforme e interoperabile con la piattaforma informativa sanitaria regionale.^[2553] La valutazione si articola infine in un monitoraggio in itinere, che accompagna l'attivazione progressiva, e in una valutazione ex post a regime.^[2554] La tabella seguente riepiloga la governance valutativa.

Elemento della governance valutativa	Scelta per la Sardegna
Disegno d'impatto	Esperimento a cunei progressivi tra le otto Aziende, con linea di base nelle Aziende non ancora dotate
Linea di base	Rilevazione nelle Aziende non ancora dotate e progressione differenziata dell'attivazione del Dipartimento
Titolarità del cruscotto	ARES e Assessorato regionale, con alimentazione uniforme dalle otto Aziende
Clausola valutativa	Da corredare all'attivazione del Dipartimento (LR 24/2020 sperimentale); relazione periodica al Consiglio regionale
Flusso informativo	Monitoraggio del Dipartimento coordinato dall'ARES; uniforme e interoperabile con la piattaforma regionale
Tempi	In itinere (accompagnamento dell'attivazione) ed ex post (effetto a regime)

Tabella L.2. La governance della valutazione e il cruscotto regionale.

L.5 Sintesi del monitoraggio

La valutazione è la condizione per trasformare l'attivazione del servizio in apprendimento, e la Sardegna può fondarla su una linea di base nelle Aziende non ancora dotate; perché ciò si realizzi, la clausola valutativa va corredata all'attivazione del Dipartimento e il flusso informativo va impostato fin dall'inizio in forma uniforme fra le otto Aziende, avvalendosi del coordinamento dell'ARES e valorizzando l'opportunità di una rilevazione ben progettata.^[2555] Definito il sistema di monitoraggio, la parte conclusiva compone i risultati dei diversi domini in una sintesi multidimensionale e formula le raccomandazioni.

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclude lo studio componendo i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo e traducendolo in raccomandazioni operative. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano i contenuti, ancorati alla Sardegna. La parte richiama la sintesi per dominio (capitolo M.1); espone l’analisi multi-criterio e il confronto fra l’intervento e il non intervento (M.2); formula la raccomandazione principale e il dimensionamento (M.3); ne precisa le condizioni e la lacuna da colmare (M.4); e chiude con la collocazione nella serie e la conclusione (M.5). Il tratto distintivo della Sardegna percorre l’intera sintesi: è la regione insulare a bassa densità e fra le più anziane d’Italia, a statuto speciale autofinanziante e con il più elevato disavanzo fra le statuto speciale, che, undicesima della serie, è chiamata non a istituire un servizio, ma ad attivare pienamente un Dipartimento già previsto per legge con un modello dipartimentale e gratuito, estendendolo dalla sola Azienda di Sassari alle otto Aziende.

M.1 La sintesi per dominio

La parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini impiegando l’analisi multi-criterio, che integra in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie, ponderandole secondo criteri espliciti.^[2556] Il quadro che emerge dai domini è coerente: il bisogno è ampio e radicato in una regione insulare a bassa densità e fra le più anziane d’Italia; l’efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida, con dati operativi propri ancora limitati; il quadro economico distingue un caso finanziario di modesto disavanzo prossimo al pareggio da un caso sociale fortemente positivo; l’equità è favorevole su un doppio asse territoriale e sulla dimensione generazionale, ed è rafforzata dalla gratuità del modello dipartimentale; la fattibilità è quella della piena attivazione di un Dipartimento già previsto per legge; il monitoraggio può fondarsi su una linea di base nelle Aziende non ancora dotate.^[2557] La tabella seguente riepiloga il giudizio per dominio.

Dominio	Giudizio sintetico per la Sardegna
Bisogno e contesto	Ampio; regione insulare a bassa densità e fra le più anziane d’Italia, a statuto speciale, disavanzo più grave fra le statuto speciale
Efficacia clinica	Evidenza internazionale solida; dati operativi propri ancora limitati (Dipartimento attivo a Sassari)
Valutazione economica	Caso finanziario di modesto disavanzo; caso sociale fortemente positivo
Equità	Favorevole su doppio asse (poli urbani/aree interne spopolate; centro/periferie) e su età anziana e disagio giovanile; rafforzata dalla gratuità
Fattibilità	Piena attivazione di un Dipartimento già previsto per legge; coordinamento ARES; vincolo del pareggio di bilancio
Monitoraggio	Disegno controfattuale su attuazione parziale, con linea di base nelle Aziende non ancora dotate e monitoraggio ARES

Tabella M.1. La sintesi dei domini della valutazione.

M.2 L'analisi multi-criterio

Il giudizio complessivo è formalizzato con l'analisi multi-criterio, che impiega otto criteri, ciascuno con un peso esplicito, e confronta l'intervento con l'alternativa del non intervento.^[2558] I pesi adottati — efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell'evidenza 10%, coerenza strategica 5% — sono comuni a tutta la serie.^[2559] La media ponderata dei punteggi dell'intervento è dell'ordine di 77,4 su 100, sostenuta dai punteggi elevati nell'equità, nel valore sociale e nel ritorno, e contenuta dai punteggi più bassi nella robustezza dell'evidenza — che riflette l'attuazione ancora parziale, con dati propri limitati — e nell'impatto sul bilancio, condizionato dal più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale.^[2560] Il non intervento ottiene una media dell'ordine di 39,2 su 100, penalizzato in tutti i criteri sostanziali e sostenuto soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, oggi poco giustificata, poiché lascerebbe inattuato in sette Aziende su otto un Dipartimento già previsto per legge.^[2561] L'intervento prevale dunque nettamente, con uno scarto dell'ordine di trentotto punti; il punteggio si colloca fra i più elevati delle regioni esaminate, riflettendo una previsione normativa acquisita e la gratuità del modello.^[2562] La prevalenza si mantiene al variare dei pesi entro intervalli ragionevoli, sicché la raccomandazione è robusta.^[2563] La tabella seguente riporta i punteggi per criterio.

Criterio	Peso	Intervento	Non interv.
Efficacia clinica	15%	80	30
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	85	25
Impatto sul bilancio e sostenibilità	15%	60	52
Equità	15%	86	28
Valore sociale	10%	85	25
Fattibilità	10%	76	84
Robustezza dell'evidenza	10%	62	55
Coerenza strategica	5%	84	26
Punteggio complessivo ponderato	100%	77,40	39,20

Tabella M.2. L'*****analisi multi-criterio: punteggi dell'*****intervento e del non intervento.

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Dalla convergenza dei domini e dall'analisi multi-criterio discende la raccomandazione principale: attivare pienamente il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie già previsto per legge, estendendolo dalla sola Azienda di Sassari a tutte le otto Aziende, adottando il provvedimento di copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione, entro il vincolo del pareggio di bilancio, e dimensionandolo verso la copertura piena del fabbisogno; è la decisione che la Sardegna, dotata di previsione di legge, è chiamata a compiere per rendere pienamente operativo il servizio.^[2564] Quanto alla scala, si raccomanda di muovere dal Dipartimento già attivato nell'Azienda di Sassari e di procedere per gradi verso lo scenario conservativo, dell'ordine di 170

psicologi, quindi verso quello di base, dell'ordine di 250, e infine verso quello espansivo, dell'ordine di 340, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità.^[2565] La tabella seguente riepiloga le raccomandazioni operative.

Ambito	Raccomandazione operativa per la Sardegna
Atto di attuazione	Attivare pienamente il Dipartimento; estenderlo dalla sola Azienda di Sassari alle otto Aziende; adottare la copertura finanziaria
Dimensionamento	Dal Dipartimento di Sassari verso conservativo ~170; base ~250; espansivo ~340, per gradi
Allocazione	Pro-equità, verso le aree interne spopolate, le periferie dei poli, l'età anziana e il disagio giovanile; modello gratuito
Clausola valutativa	Corredarla all'attivazione del Dipartimento (LR 24/2020 sperimentale); relazione periodica al Consiglio regionale
Governance	Regia dell'Azienda regionale della salute (ARES); indirizzi uniformi; flusso informativo da impostare fin dall'attivazione
Dati	Estrarre i conti certificati delle otto Aziende; impostare i dati di esito uniformi via monitoraggio del Dipartimento

Tabella M.3. Le raccomandazioni operative.

M.4 Le condizioni e la lacuna da colmare

La raccomandazione è subordinata a condizioni precise: la costruzione di una clausola valutativa a corredo dell'attivazione del Dipartimento, l'adozione di un'allocazione pro-equità verso le aree interne, la regia dell'Azienda regionale della salute (ARES) e l'impostazione fin dall'attivazione di un flusso informativo uniforme fra le otto Aziende.^[2566] Resta inoltre da colmare, prima della presentazione esterna, la lacuna dei dati: l'estrazione dei conti certificati delle otto Aziende socio-sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e l'impostazione di un flusso uniforme dei dati di esito via monitoraggio del Dipartimento consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive.^[2567] Va infine ribadita la distinzione cardine: il caso finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, mentre il caso economico complessivo è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto.^[2568]

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio sulla Sardegna è l'undicesimo della serie, dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria, Lazio, Campania e Sicilia, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, la Sardegna occupa una posizione propria — quella della regione insulare a bassa densità e fra le più anziane d'Italia, a statuto speciale autofinanziante e con il più elevato disavanzo fra le statuto speciale, che ha previsto il Dipartimento in una legge di riforma con un modello dipartimentale e gratuito e lo ha attivato nella sola Azienda di Sassari — e che oggi è chiamata ad attivarlo pienamente e a estenderlo alle otto Aziende.^[2569] Coerentemente con l'impostazione dell'intero progetto, lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico, e adotta un rapporto beneficio-costi prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, per credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica.^[2570] La decisione che lo

studio sostiene è, in conclusione, di attivare pienamente il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie già previsto per legge, estendendolo dalla sola Azienda di Sassari a tutte le otto Aziende, adottando il provvedimento di copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno e corredandolo di una clausola valutativa: per la Sardegna, dotata di previsione di legge e di un modello dipartimentale gratuito, ciò significa rendere effettivo un servizio già previsto, a beneficio della popolazione.^[2571]

Valle d'Aosta — Studio HTA integrale

Studio Integrale Regionale · Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Progetto «Psicologo di Base» — Prima istituzione del servizio in una piccola regione alpina a statuto speciale, autonomia finanziaria integrale e alta spesa sanitaria pro-capite. Applicazione del telaio integrato in undici parti e cinque appendici (Modello HTA · Five Case Model · CHEERS 2022 · criteri OCSE-DAC).

Indice

Premessa generale

Questo documento apre e ordina lo studio integrale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sul progetto «Psicologo di Base». Esso non contiene una nuova analisi, ma fornisce la chiave di navigazione dell'intero corpus: la premessa, l'indice generale di tutte le parti e di tutte le appendici, la mappa di integrazione delle cornici metodologiche e la sintesi del valore. La Valle d'Aosta occupa, nel panorama nazionale e in questa serie, una posizione propria e marcata: è la più piccola regione italiana per numero di abitanti — 122.532 residenti al 1° gennaio 2025, in lieve stabilizzazione dopo un decennio di calo demografico^[2572] — ma anche una delle più ricche e delle più anziane, con la terza spesa sanitaria pubblica pro-capite d'Italia secondo le stime ISTAT 2022 (2.526 euro) e, secondo il più recente rapporto della Fondazione GRINS, la seconda spesa sanitaria pesata pro-capite dopo il Trentino-Alto Adige, nell'ordine di 3.465-3.503 euro.^[2573] Al pari del Trentino-Alto Adige, essa è una regione autonoma a statuto speciale che si autofinanzia integralmente la sanità trattenendo sul proprio territorio la quasi totalità del gettito tributario, senza apporto a carico del Bilancio dello Stato; è bilingue — italiano e francese, con tutela costituzionale del francese — e integralmente alpina, con bassissima densità abitativa e una struttura di servizi concentrata nell'unico capoluogo regionale, Aosta, mentre la gran parte del territorio è costituita da vallate laterali a popolazione dispersa.^[2574]

La Valle d'Aosta non ha ancora istituito, in nessuna forma, il servizio di psicologo di base: nessuna legge regionale e nessun atto programmatico hanno finora avviato il percorso.^[2575] La decisione rilevante è dunque quella di istituire il servizio per la prima volta, in un territorio che presenta condizioni di partenza molto particolari rispetto a qualunque altra regione della serie: dimensione demografica minima, invecchiamento fra i più acuti d'Italia, alto benessere economico, piena autonomia finanziaria, bilancio sanitario in equilibrio e articolato in un'unica azienda sanitaria regionale — l'Azienda USL Valle d'Aosta — con quattro distretti su un territorio integralmente montano e con servizi di salute mentale già strutturati, ma non un servizio di psicologia delle cure primarie.

Il corpus si compone di sedici documenti: undici parti narrative, dalla A alla M — l'alfabeto italiano salta le lettere J e K — e cinque appendici, dalla A alla E. Le parti seguono l'ordine dei domini della valutazione di tecnologia sanitaria, dal problema di salute alla sintesi, e ciascuna sviluppa i propri capitoli con il relativo apparato di note. Le appendici raccolgono il caso di riferimento e i parametri, gli strumenti di esito e il dataset minimo, i dati regionali e le fonti, gli standard di reporting e il glossario.

Indice generale del corpus

La tabella seguente elenca i sedici documenti dello studio, con i rispettivi capitoli e il contenuto.

Documento	Capitoli	Contenuto
Parte A	A.1-A.3	Quadro, quesito e metodo: scopo e quesito (PICOTS), caso di riferimento, governance dei dati
Parte B	B.1-B.6	Problema di salute, bisogno e contesto: demografia, epidemiologia, domanda e offerta, disuguaglianze, flussi, normativa
Parte C	C.1-C.6	L'intervento e il modello: definizione, modello organizzativo, percorso, sistema informativo, IA, formazione
Parte D	D.1-D.4	Efficacia clinica ed evidenza: revisione sistematica, qualità GRADE, benchmark, trasferibilità
Parte E	E.1-E.6	Valutazione economica: costi, esiti, costo-utilità, impatto di bilancio, ritorno sociale, casi economico e finanziario
Parte F	F.1-F.5	Modellazione e incertezza: modello di Markov, parametri, sensibilità, verifica empirica, valore dell'informazione
Parte G	G.1-G.4	Equità e impatto distributivo: analisi di equità, assi territoriali, strumenti, costo-efficacia distributiva
Parte H	H.1-H.4	Profili etico, giuridico e organizzativo: giuridico, organizzativo, etico, sintesi
Parte I	I.1-I.5	Attuazione, fattibilità e sostenibilità: cinque casi, dimensionamento, cronoprogramma, sostenibilità, rischi
Parte L	L.1-L.5	Monitoraggio e valutazione ex post: impianto, disegno controfattuale, indicatori, cruscotto, sintesi
Parte M	M.1-M.5	Sintesi multidimensionale e raccomandazioni: sintesi per dominio, analisi multi-criterio, raccomandazioni, condizioni, conclusione
Appendice A	—	Caso di riferimento e parametri: tavola delle assunzioni e dei parametri
Appendice B	—	Strumenti di esito e dataset minimo: questionari e dizionario dei dati
Appendice C	—	Dati del territorio e fonti: valori di ancoraggio e dati da acquisire
Appendice D	—	Checklist di reporting: CHEERS, PRISMA, GRADE, STROBE, ISPOR-SMDM, OCSE-JRC
Appendice E	—	Glossario: definizioni dei termini tecnici

Tabella 1. L'indice generale del corpus: le undici parti narrative e le cinque appendici.

La mappa di integrazione del telaio

L'integrazione delle quattro cornici non è una giustapposizione, ma una composizione ordinata: la macro-struttura è data dai domini del modello HTA, che fissano le parti; il Five Case Model alloca i suoi cinque casi alle parti pertinenti; la valutazione economica è redatta secondo lo standard CHEERS; e i criteri dell'OCSE-DAC attraversano l'intero studio quale griglia di giudizio, convergendo nella sintesi finale. La tabella seguente ne dà conto, parte per parte.

Parte	Dominio HTA	Caso (5CM)	Criterio OCSE-DAC
A — Quadro e metodo	Trasversale	—	Imposta la griglia
B — Bisogno e contesto	Dominio 1	Strategico	Rilevanza, coerenza
C — Intervento e modello	Domini 2-3	Strategico	—
D — Efficacia ed evidenza	Dominio 4	Economico	Efficacia
E — Valutazione economica	Dominio 5	Economico, finanziario	Efficienza
F — Modellazione e incertezza	Dominio 5	Economico	Efficienza
G — Equità e impatto	Dominio 8	Economico	Impatto
H — Profili etico/giuridico/organizz.	Domini 6, 7, 9	Gestionale	Coerenza
I — Attuazione e sostenibilità	Dominio 7	Commerciale, gestionale	Sostenibilità
L — Monitoraggio ed ex post	Trasversale	—	Verifica ex post
M — Sintesi e raccomandazioni	Trasversale	Strategico	Tutti i criteri

Tabella 2. La mappa di integrazione delle quattro cornici, parte per parte.

La sintesi del valore

La sintesi economica dello studio, sviluppata nelle Parti E e M, è qui riepilogata quale chiave di lettura dell'intero corpus. Per la Valle d'Aosta — come per il Trentino-Alto Adige, al quale la accomuna la piena autonomia finanziaria, l'alto livello di spesa pro-capite e la natura di piccola regione alpina a statuto speciale — il quadro consolidato per scenario distingue i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali, e ne ricava il saldo diretto — lievemente negativo ma modesto e agevolmente sostenibile, poiché il sistema, già ben finanziato, lascia margini di recupero diretto contenuti — e il saldo complessivo, ampiamente positivo. La scala è naturalmente molto più ridotta rispetto a qualunque altra regione della serie, in ragione della popolazione nove volte inferiore a quella del Trentino-Alto Adige.

Componente (mln €/anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 1,5	~ 2,0	~ 2,6
Risparmi diretti (SSR)	~ 0,7	~ 1,1	~ 1,6
Ricadute economico-sociali	~ 4,5	~ 7,0	~ 9,5
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -0,8	~ -0,9	~ -1,0
Saldo complessivo (caso economico)	~ +3,7	~ +8,1	~ +12,1 (appross.)
Rapporto beneficio-costo complessivo	~4,0:1	~4,8:1	~5,3:1

Tabella 3. Il quadro economico consolidato per scenario (sintesi delle Parti E e M).

Da questa sintesi discendono la raccomandazione centrale e la dichiarazione del limite principale. La raccomandazione è che la Valle d'Aosta è chiamata a istituire per la prima volta un servizio di psicologia delle cure primarie, dimensionandolo per gradi verso la copertura sistematica: nell'ordine di 15 psicologi nello scenario conservativo, 22 in quello di base e 30 in quello espansivo, con un'unica azienda sanitaria che semplifica il governo del percorso. Il limite principale è il radicamento dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione (circa lo 0,2% del totale nazionale) e non estratte dai conti certificati dell'Azienda USL; la priorità è l'estrazione di questi dati come condizione per la presentazione agli organi di controllo della finanza pubblica regionale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte A

Quadro, quesito e metodo

Scopo e quesito di valutazione, caso di riferimento e metodi, governance e protezione dei dati

Dominio trasversale dell'HTA · imposta la griglia di valutazione

Parte A — Quadro, quesito e metodo

Questa è la prima parte dello studio integrale per la Valle d'Aosta, che applica al territorio il telaio integrato sviluppato e validato per la Puglia e già esteso alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria, al Lazio, alla Campania, alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, alle Marche, alla Basilicata, al Molise e alle altre regioni della serie. L'architettura e il caso di riferimento sono i medesimi, e mutano soltanto i dati di ingresso, ancorati alla Valle d'Aosta. In questa architettura la Parte A precede i domini della valutazione e ne fonda l'impianto: stabilisce che cosa si valuta e perché, fissando lo scopo e il quesito (capitolo A.1); come lo si valuta, fissando il caso di riferimento e i metodi (capitolo A.2); e sotto quali garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati l'analisi procede (capitolo A.3). La Valle d'Aosta occupa nella serie una posizione del tutto peculiare: è la regione più piccola d'Italia per popolazione, l'unica interamente alpina, una delle più anziane e delle più ricche, a piena autonomia finanziaria, e priva di qualunque forma di servizio di psicologo di base; la valutazione riguarda perciò l'opportunità e le modalità di una prima istituzione.

A.1 Scopo, quesito di valutazione e standard adottati

Lo studio ha per oggetto il servizio di psicologia delle cure primarie della Valle d'Aosta, inteso come primo livello di ascolto psicologico integrato nella rete territoriale dell'Azienda USL, accessibile a tutti i residenti con disagio psichico comune o sottosoglia. Ne valuta il valore nelle dimensioni clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e giuridica, allo scopo di informare la decisione sulla sua istituzione.^[2576] La premessa che orienta l'intero studio è che la decisione rilevante, per la Valle d'Aosta, è istituire per la prima volta un servizio che non esiste in nessuna forma: non vi è una legge regionale, non vi è una sperimentazione in corso, non vi è un modello parziale da completare.^[2577] Lo studio fornisce gli elementi per quella decisione, non la sostituisce: ne misura le conseguenze attese in tre scenari di copertura, lasciando alla sede politica e di bilancio la scelta della scala.

Il quesito è articolato secondo lo schema che ne fissa gli elementi costitutivi. La popolazione è costituita dai residenti della Valle d'Aosta con bisogno psicologico comune — nell'ordine di 24.000-25.000 persone con disagio psichico comune secondo le stime di prevalenza nazionali applicate alla popolazione regionale — e in seconda istanza dall'intera popolazione per gli effetti di sistema. L'intervento è il servizio di psicologia delle cure primarie, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro, da istituire ex novo nell'unica azienda sanitaria regionale, integrato nella rete delle Case della Comunità e dei poliambulatori distrettuali. Il confronto è l'assenza del servizio, nella quale il bisogno psicologico comune non è sistematicamente intercettato a livello di cure primarie e refluisce sui servizi specialistici o rimane non trattato. Gli esiti sono clinici, economici, sociali e di sistema. I tempi distinguono l'orizzonte pluriennale degli esiti dall'orizzonte triennale-quinquennale del bilancio. Il contesto è dato dall'Azienda USL Valle d'Aosta, con i suoi quattro distretti su un territorio integralmente montano, dall'Ospedale regionale Umberto Parini come presidio principale, e dal sistema bilingue italiano-francese. La tabella seguente riepiloga gli elementi del quesito.

Elemento	Definizione per la Valle d'Aosta
Popolazione	Residenti con disagio psichico comune (~24.000-25.000); in seconda istanza l'intera popolazione per gli effetti di sistema
Intervento	Servizio di psicologo di base, primo livello e filtro (~15/22/30 psicologi nei tre scenari); da istituire ex novo
Confronto	Assenza del servizio: bisogno comune non intercettato sistematicamente a livello di cure primarie
Esiti	Clinici (recupero, miglioramento affidabile); economici (risparmi diretti, ritorno complessivo); sociali; di sistema
Tempi	Orizzonte pluriennale per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Contesto	Azienda USL Valle d'Aosta (unica); quattro distretti montani; Ospedale Parini; bilinguismo italiano-francese; statuto speciale

Tabella A.1. Il quesito di valutazione nei suoi elementi costitutivi.

Lo studio adotta quattro cornici metodologiche apicali, ciascuna con una funzione distinta: il modello centrale dell'HTA, che ne fissa i domini e ne garantisce la completezza; il Five Case Model, che ne ordina i contenuti in una decisione di investimento pubblico; lo standard CHEERS, che ne governa il reporting economico; e i criteri dell'OCSE-DAC, che ne forniscono la griglia di giudizio. In tali cornici sono innestate dieci metodologie analitiche, ciascuna nella sede di sua competenza, e l'intero studio è redatto secondo gli standard di reporting riconosciuti, a garanzia di trasparenza e riproducibilità.

A.2 Il caso di riferimento e i metodi

Il caso di riferimento è l'insieme delle scelte metodologiche di base che rendono i risultati interpretabili e confrontabili, fissate una volta e mantenute per tutte le Regioni.^[2578] Lo studio adotta la doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, distinguendo i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute per la collettività; un orizzonte pluriennale o di intera vita per gli esiti di salute e triennale-quinquennale per il bilancio; un tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto previsto per i benefici di salute; gli anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; e l'assenza del servizio come comparatore. Le unità di analisi sono il territorio regionale e, in disaggregazione, i quattro distretti, per dare conto dei divari territoriali interni, segnatamente fra il distretto di Aosta e le vallate laterali a popolazione dispersa, e della dimensione bilingue.

Parametro	Scelta per lo studio
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con distinzione tra diretto e sociale
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti; verifica al tasso ridotto per i benefici di salute
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Assenza del servizio di psicologo di base: cura usuale senza intercettazione psicologica di primo livello
Unità di analisi	Territorio regionale, con disaggregazione per distretto (Morgex, Aosta, Châtillon, Verrès-Donnas)
Correzione per ottimismo	Adozione del valore centrale o conservativo per le conclusioni

Tabella A.2. Il caso di riferimento dello studio, comune a tutte le Regioni.

Una scelta tecnica merita di essere esplicitata, perché distingue due grandezze che lo studio tiene rigorosamente separate. L'analisi di impatto sul bilancio opera su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità, invece, attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute al medesimo tasso. Nel caso della Valle d'Aosta, la piena autonomia finanziaria e la solidità del bilancio regionale rendono il vincolo finanziario non il limite principale; il costo contenuto del servizio, rapportato alla dimensione ridottissima della popolazione, rappresenta una quota dell'ordine dello 0,5-0,8% del Fondo sanitario regionale anche nello scenario espansivo, agevolmente compatibile con le risorse disponibili.^[2579] Il margine di recupero diretto di bilancio è più contenuto che nelle regioni sotto-finanziate, poiché il sistema è già ben dotato e lascia meno consumo improprio recuperabile; ne consegue un saldo diretto lievemente negativo, ma il caso economico complessivo è nettamente positivo, fondato prevalentemente sulle ricadute sociali.^[2580]

Le dieci metodologie selezionate sono distribuite nelle parti dello studio secondo la loro funzione. La valutazione economica impiega l'analisi costo-utilità per il costo per esito di salute, l'analisi di impatto sul bilancio per la sostenibilità finanziaria e il ritorno sociale per il valore generato oltre il bilancio; la modellazione decisionale proietta costi ed esiti nel tempo, e la sensibilità probabilistica con il valore dell'informazione ne

governa l'incertezza; la costo-efficacia distributiva misura l'equità; l'inferenza causale quasi-sperimentale stima l'effetto reale; la revisione sistematica con il sistema GRADE fonda l'evidenza; l'analisi multi-criterio compone i criteri non monetari; l'analisi di impatto della regolamentazione valuta la norma ex ante ed ex post.

Metodologia	Sede	Funzione
Costo-utilità	Parte E	Costo per esito di salute
Impatto sul bilancio	Parte E	Sostenibilità finanziaria per il bilancio regionale
Ritorno sociale	Parte E	Valore generato oltre il bilancio
Modellazione decisionale	Parte F	Proiezione di costi ed esiti nel tempo
Sensibilità probabilistica e valore dell'informazione	Parte F	Governo dell'incertezza e priorità di ricerca
Costo-efficacia distributiva	Parte G	Misura dell'equità distributiva
Inferenza causale quasi-sperimentale	Parte L	Stima dell'effetto reale sul campo
Revisione sistematica e sistema GRADE	Parte D	Fondazione e graduazione dell'evidenza
Analisi multi-criterio	Parte M	Composizione dei criteri non monetari
Analisi di impatto della regolamentazione	Parti H, L	Valutazione della norma ex ante ed ex post

Tabella A.3. Le dieci metodologie analitiche e la loro collocazione nello studio.

A.3 Governance della valutazione, etica e protezione dei dati

La valutazione non è un esercizio puramente tecnico, ma procede sotto garanzie di governo, etiche e di protezione dei dati che ne assicurano la legittimità e l'attendibilità. Sul piano del governo, lo studio è riferito a un comitato di indirizzo che riunisce la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Assessorato regionale alla salute, l'Azienda USL Valle d'Aosta, l'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e il polo universitario valdostano.^[2581] La caratteristica propria della Valle d'Aosta è che la materia sanitaria è di competenza regionale piena, in forza dello statuto speciale, e che l'unica azienda sanitaria è organizzata in quattro distretti che coprono un territorio integralmente montano, con forti asimmetrie di accessibilità fra la conca di Aosta e le vallate laterali; il bilinguismo italiano-francese costituisce un elemento istituzionale strutturale che la valutazione assume quale vincolo organizzativo e fattore di equità.

Sul piano della protezione dei dati, il trattamento è conforme alla normativa vigente, ispirato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza, con la piattaforma informativa sanitaria regionale quale infrastruttura per la raccolta uniforme. Gli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati nel servizio sono concepiti come ausilio del clinico, mai come sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale. Sul piano etico, lo studio adotta particolari cautele a tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti. Con la definizione del quadro, del quesito e del metodo, lo studio dispone delle fondamenta su cui poggiano i domini successivi: la parte che segue affronta il problema di salute, il bisogno e il contesto della Valle d'Aosta.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte B

Problema di salute, bisogno e contesto

Quadro demografico, epidemiologia del bisogno, domanda e offerta, disuguaglianze, servizi e flussi, cornice normativa

Primo dominio dell'HTA · il problema di salute e il bisogno

Parte B — Problema di salute, bisogno e contesto

Definito nella Parte A il quadro metodologico, questa seconda parte affronta il primo dominio della valutazione: il problema di salute, il bisogno e il contesto della Valle d'Aosta. La struttura è quella già adottata per le altre regioni della serie, e mutano soltanto i dati, ancorati al territorio. La parte muove dal quadro demografico (capitolo B.1) e dall'epidemiologia del bisogno (B.2); ne ricava la relazione tra domanda, offerta e gap di copertura (B.3); analizza le disuguaglianze e i divari territoriali (B.4); descrive i servizi e i flussi del sistema sanitario regionale rilevanti per l'intervento (B.5); e ricostruisce la cornice normativa e programmatica entro cui la decisione si colloca (B.6). Ne emerge il tratto specifico della Valle d'Aosta: una regione molto piccola, molto anziana, alpina e bilingue, a piena autonomia finanziaria, in cui il servizio di psicologo di base è assente e la domanda di salute mentale di primo livello non è sistematicamente intercettata.

B.1 Quadro demografico

La Valle d'Aosta conta 122.532 residenti al 1° gennaio 2025, in lieve stabilizzazione dopo un decennio di calo demografico, con una popolazione che si è fermata a 122.554 al 1° gennaio 2026.^[2582] Si tratta della regione più piccola d'Italia per popolazione, pari a circa lo 0,21% del totale nazionale. La struttura per età è marcatamente anziana: l'indice di vecchiaia è pari a 215,1 nel 2023, fra i più alti d'Italia, con una quota di over-65 che si attesta al 25,79% nel 2025 e che, secondo le proiezioni IRES Valle d'Aosta, raggiungerà il 34,13% nel 2040.^[2583] La Valle d'Aosta è bilingue per norma costituzionale — italiano e francese — con una quota di stranieri residenti dell'ordine del 9-10% della popolazione. Il territorio è integralmente alpino e montano, con una densità abitativa fra le più basse d'Italia (circa 39 ab/km²), concentrata nel fondovalle centrale e nel capoluogo Aosta, mentre una quota rilevante della popolazione risiede in piccoli comuni nelle vallate laterali. L'Azienda USL Valle d'Aosta articola il territorio in quattro distretti sanitari: Distretto 1 (Morgex/Gran San Bernardo), Distretto 2 (Aosta), Distretto 3 (Châtillon/Saint-Vincent), Distretto 4 (Verrès/Donnas). La tabella seguente riepiloga il profilo demografico e socio-economico.

Indicatore	Valore per la Valle d'Aosta
Popolazione (2025)	122.532 (0,21% del totale nazionale); in lieve stabilizzazione dopo un decennio di calo; unica regione interamente alpina d'Italia
Età e salute	Indice di vecchiaia 215,1 (2023), fra i più alti d'Italia; over-65: 25,79% (2025), proiettato al 34,13% (2040); speranza di vita elevata
Composizione linguistica	Italiano e francese, con tutela costituzionale del francese; stranieri ~9-10% della popolazione; bilingue per norma costituzionale
Distribuzione territoriale	Fondovalle centrale e capoluogo Aosta; vallate laterali a densità abitativa molto bassa (~39 ab/km ²); quattro distretti sanitari
Profilo economico	Reddito pro-capite fra i più alti d'Italia; economia basata su turismo, attività terziarie, industria idroelettrica e attività montane
Articolazione sanitaria	Azienda USL Valle d'Aosta (unica); Ospedale Parini (Aosta) presidio principale; quattro distretti su territorio montano; bilinguismo italiano-francese

Tabella B.1. Profilo demografico e socio-economico della Valle d'Aosta.

B.2 Epidemiologia del bisogno

Il bisogno di salute mentale nella Valle d'Aosta è rilevante e presenta tratti propri. Applicando i tassi di prevalenza nazionale del disagio psichico comune — nell'ordine del 20% della popolazione — alla popolazione valdostana, il numero di persone con bisogno potenziale si colloca nell'ordine di 24.000-25.000. Tale stima è coerente con i dati locali disponibili: il tasso standardizzato di incidenza dei casi trattati dai servizi di salute mentale è di 118,5 per 10.000 abitanti — il più alto d'Italia rispetto alla media nazionale di 55,4 — indicando un sistema di salute mentale attivo e aperto, ma anche un bisogno sottostante elevato.^[2584] Il Centro di Salute Mentale di Aosta ha registrato oltre 400 accessi nei soli primi mesi dall'apertura nella nuova sede nel 2024, segno di una domanda sostenuta.^[2585] La struttura per età molto anziana della popolazione amplifica la componente del bisogno connessa alla depressione tardiva e ai disturbi cognitivi, e la dimensione dell'isolamento nelle vallate laterali costituisce un fattore di rischio aggiuntivo. Tre componenti orientano il bisogno in modo specifico. La prima è il disagio dell'anzianità, trainato dall'invecchiamento accelerato, che prefigura una domanda crescente di sostegno psicologico nell'età avanzata. La seconda è il disagio connesso all'isolamento geografico nelle vallate laterali, dove le distanze e la stagionalità turistica limitano l'accesso ai servizi. La terza è la pressione sul pronto soccorso e sui servizi specialistici, che assorbe una quota di bisogno che potrebbe essere intercettata a livello di cure primarie.

B.3 Domanda, offerta e gap di copertura

Alla domanda descritta si contrappone, in Valle d'Aosta, un'offerta di psicologia di primo livello assente: non vi è un servizio di psicologo di base, né una legge regionale che lo istituisca, né una sperimentazione in corso.^[2586] Il sistema di salute mentale dispone dei Centri di Salute Mentale, di strutture residenziali e semiresidenziali e di un Servizio di Psichiatria ospedaliera nel Presidio Parini, ma non di un servizio psicologico delle cure primarie integrato nella medicina generale. Il fabbisogno a regime è stimato nell'ordine di 30 psicologi nello scenario espansivo, per analogia proporzionale con il Trentino-Alto Adige — che ne conta

240 per una popolazione circa nove volte superiore — e con gli standard internazionali; il gap di copertura è dunque totale rispetto al fabbisogno, per mancanza del servizio. La tabella seguente sintetizza domanda, offerta e divario.

Grandezza	Valore per la Valle d’Aosta
Disagio comune (bisogno potenziale)	~ 24.000-25.000 persone
Utenza in carico ai servizi di salute mentale	Nell’ordine di alcune migliaia (stima rapportata ai dati nazionali e al tasso di incidenza locale di 118,5/10.000)
Offerta territoriale attuale	Nessun servizio di psicologo di base; Centri di Salute Mentale presenti; nessuna legge regionale e nessuna sperimentazione in corso
Fabbisogno stimato a regime	~ 30 psicologi nello scenario espansivo; ~ 22 in quello di base; ~ 15 in quello conservativo
Copertura attuale del fabbisogno	Zero: servizio assente in tutte le sue forme

Tabella B.2. Domanda, offerta e gap di copertura.

B.4 Disuguaglianze e divari territoriali

La dimensione distributiva del bisogno, in Valle d’Aosta, si gioca su due assi. Il primo, territoriale, separa il fondovalle centrale e il capoluogo Aosta — dove si concentrano i servizi e la maggior parte della popolazione — dalle vallate laterali (Gran San Bernardo, Cervinia, Gressoney, Champorcher), dove l’orografia, le distanze e la stagionalità turistica rendono l’accesso a qualunque servizio sanitario significativamente più difficoltoso, e dove risiedono quote non trascurabili di popolazione anziana. Il secondo è quello socio-economico e linguistico: pur in una regione relativamente ricca nel complesso, la componente di lavoratori del settore turistico-stagionale e quella degli immigrati di lingua francofona presentano vulnerabilità specifiche nell’accesso ai servizi. Su questi divari il modello del psicologo di base agisce in funzione di equità: avvicina l’offerta al territorio mediante la telepsicologia assistita nei comuni più remoti, e garantisce la disponibilità bilingue del servizio come condizione di accesso effettivo per i residenti di madrelingua francese o per coloro che preferiscono esprimersi in francese.

B.5 I servizi e i flussi

L’Azienda USL Valle d’Aosta dispone della spesa sanitaria pubblica pro-capite fra le più elevate d’Italia: 2.526 euro nel 2022 secondo l’ISTAT (terza in Italia dopo le Province autonome di Trento e Bolzano), con un finanziamento pro-capite che, secondo dichiarazioni dell’Assessore regionale Marzi nel dicembre 2024, ha raggiunto circa 3.750 euro nel 2024;^[2587] le stime della Fondazione GRINS collocano la spesa sanitaria pesata pro-capite della Valle d’Aosta al secondo posto in Italia, nell’ordine di 3.465-3.503 euro.^[2588] Il Fondo sanitario regionale è determinato dalla legge di stabilità regionale nell’ordine di 333 milioni di euro per il 2024, con una quota trasferita all’Azienda USL di 319 milioni.^[2589] Il profilo di mobilità sanitaria è di saldo lievemente negativo — 10,9 milioni nel 2024, con crediti per 17 milioni e debiti per 27,9 milioni — ma di entità

modesta e non strutturalmente problematico.^[2590] La spesa sanitaria privata delle famiglie valdostane è la seconda più alta d'Italia in rapporto al PIL regionale, pari al 3% contro il 2,2% della media nazionale.^[2591] La tabella seguente riepiloga le grandezze di sistema rilevanti.

Grandezza di sistema	Valore per la Valle d'Aosta
Finanziamento del SSR	Autofinanziamento integrale con quota analoga ai 9/10 del gettito trattenuto, senza apporto statale; FSR ~333 mln (2024); spesa pro-capite fra le più alte d'Italia; bilancio in equilibrio
Mobilità sanitaria	Saldo lievemente negativo: -10,9 mln (2024), crediti 17 mln, debiti 27,9 mln; entità modesta; canale del recupero contenuto per questo intervento
Pronto soccorso	Accessi per cause psichiatriche alimentati anche da bisogno di primo livello non intercettato; costi amplificati dai trasferimenti dalle vallate
Architettura dei servizi	Azienda USL Valle d'Aosta (unica); quattro distretti; Ospedale Parini (Aosta) presidio principale; Centri di Salute Mentale presenti; nessun psicologo di base
Margine di azione principale	Prima istituzione del servizio; accesso nelle vallate laterali; bilinguismo italiano-francese; disagio dell'anzianità; intercettazione precoce

Tabella B.3. I servizi e i flussi dell'Azienda USL Valle d'Aosta rilevanti per l'intervento.

B.6 La cornice normativa e programmatica

La decisione si colloca entro una cornice che deve essere ricostruita per la Valle d'Aosta con precisione. Sul piano nazionale, il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale prevede la figura dello psicologo nelle Case della Comunità, e il testo unificato in discussione alla Camera avanza verso l'istituzione del psicologo di base come livello essenziale di assistenza; ma né l'uno né l'altro sono ancora diventati operativi in Valle d'Aosta. Sul piano regionale, la Valle d'Aosta non ha approvato alcuna legge che istituisca il psicologo di base, e non risulta alcuna sperimentazione locale in corso: essa figura fra le regioni prive di previsione normativa nella mappatura aggiornata al 2025,^[2592] accanto a Marche, Molise, Basilicata, Calabria e Trentino-Alto Adige/Südtirol. La Valle d'Aosta opera entro una piena autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale, che le consente di finanziare il servizio con le risorse proprie senza attendere l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza statali; la decisione rilevante è dunque di istituire il servizio con un atto di legge regionale o con delibera della Giunta regionale che ne fissi il modello, l'organizzazione e il finanziamento. È il tema che le parti successive sviluppino, a partire dalla definizione dell'intervento e del suo modello.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte C

L'intervento e il suo modello

Definizione e teoria del cambiamento, modello organizzativo, percorso clinico, sistema informativo, strumenti digitali, formazione

Secondo e terzo dominio dell'HTA · l'intervento e la sua descrizione

Parte C — L'intervento e il suo modello

Definiti il quadro metodologico nella Parte A e il problema di salute nella Parte B, questa terza parte descrive l'intervento e il suo modello. Come per le altre regioni, la struttura è invariante e mutano i soli elementi di contesto. La parte definisce l'intervento e ne esplicita la teoria del cambiamento (capitolo C.1); ne disegna il modello organizzativo (C.2); ne specifica il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti (C.3); ne descrive il sistema informativo e l'interoperabilità (C.4); ne illustra gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale (C.5); e ne definisce il programma formativo (C.6). Il tratto specifico della Valle d'Aosta emerge con nettezza: si tratta di istituire ex novo, in una regione piccola e interamente alpina, un servizio che non esiste in nessuna forma, integrandolo nella rete dell'unica azienda sanitaria regionale e nelle quattro Case della Comunità o nei poliambulatori distrettuali, con attenzione al bilinguismo e all'accesso nelle vallate remote.

C.1 Definizione e teoria del cambiamento

Lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico integrato nelle cure primarie: intercetta precocemente il disagio, offre interventi brevi e svolge una funzione di filtro verso i servizi specialistici, che precede e alleggerisce senza sostituire. La logica dell'intervento si lascia ricostruire come una catena che collega il bisogno alle sue conseguenze attese: dal disagio comune diffuso e non intercettato — nell'ordine di 24.000-25.000 persone — attraverso la presa in carico psicologica di prossimità, agli esiti clinici, di sistema e sociali, per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria. La tabella seguente ne espone gli anelli.

Elemento della catena	Contenuto per la Valle d'Aosta
Bisogno	~ 24.000-25.000 persone con disagio comune, attualmente non intercettato a livello di cure primarie
Attività	Psicologo di base: intercettazione precoce, intervento breve, filtro verso i servizi specialistici; primo livello, ex novo
Esito clinico	Recupero e riduzione dei sintomi nei quadri lievi e moderati
Esito di sistema	Meno accessi impropri al pronto soccorso, meno farmaci inappropriati, liste di attesa ridotte ai CSM
Esito sociale	Recupero di produttività e funzionamento, minor carico familiare, riduzione dell'isolamento nelle vallate
Meccanismo	Prevenzione secondaria: intercettare prima della cronicizzazione

Tabella C.1. La teoria del cambiamento dell'intervento, dal bisogno agli esiti.

C.2 Il modello organizzativo

Il modello organizzativo colloca lo psicologo delle cure primarie nelle Case della Comunità e nei poliambulatori distrettuali, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i servizi di salute mentale dell'Azienda USL. Nella Valle d'Aosta la sfida organizzativa principale è duplice: la prima è garantire la copertura equa dei quattro distretti, con particolare attenzione alle vallate laterali più remote, dove l'accessibilità fisica è limitata dall'orografia e dalla stagionalità; la seconda è assicurare l'erogazione del servizio in entrambe le lingue ufficiali, italiano e francese, come condizione di accesso effettivo per tutti i residenti. La rete territoriale delle Case della Comunità, in costruzione in applicazione del

DM 77/2022, è l’infrastruttura su cui il servizio va innestato, con presenze programmate nelle sedi distrettuali e nei comuni più popolosi delle vallate. Il funzionamento segue il principio dell’intensità crescente: l’intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e cresce solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio ai Centri di Salute Mentale.^[2593]

C.3 Il percorso clinico, la sicurezza e gli esiti

Il percorso clinico prevede l’accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, una valutazione iniziale con progetto clinico individuale, un ciclo di colloqui brevi con programma di sostegno personalizzato e, nei casi che lo richiedono, l’invio appropriato ai Centri di Salute Mentale e ai servizi specialistici dell’Azienda USL. Il percorso affronta i quadri più frequenti — dalla sintomatologia ansioso-depressiva ai problemi di adattamento e ai disturbi psicosomatici — con particolare attenzione al bisogno dell’anzianità, prevalente in una delle regioni più anziane d’Italia, e al disagio connesso all’isolamento nelle vallate. Gli esiti sono misurati con strumenti validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario a nove voci sui sintomi depressivi (PHQ-9) e la scala a sette voci per il disturbo d’ansia generalizzata (GAD-7). Le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti.

Tipologia di esito	Indicatori
Esito primario	Quota di miglioramento clinico e tasso di recupero (PHQ-9, GAD-7)
Esiti clinici secondari	Remissione; riduzione dei punteggi; soddisfazione e qualità di vita
Esiti di processo	Prese in carico; attesa al primo colloquio; colloqui per persona; tasso di invio appropriato
Esiti di impatto e utilizzo	Accessi al pronto soccorso connessi; psicofarmaci; consulti e ricoveri evitabili

Tabella C.2. Le categorie di esito clinico e organizzativo del percorso.

C.4 Il sistema informativo e l’interoperabilità

La registrazione strutturata dell’attività e degli esiti, integrata con il sistema informativo dell’Azienda USL e con il fascicolo sanitario elettronico, è condizione del monitoraggio continuo e della valutazione. La Valle d’Aosta dispone di un’unica azienda sanitaria, il che semplifica significativamente il coordinamento informativo rispetto alle regioni con più aziende: la raccolta uniforme dei dati di processo e di esito può essere impostata fin dall’avvio del servizio in forma strutturata e completa, costituendo una base di dati propri che consentirà, nel tempo, di sostituire le stime ricavate dai benchmark con grandezze effettive. Il sistema informativo deve assicurare la disaggregazione per distretto e per vallata, per consentire la verifica dell’equità di accesso, e la compatibilità bilingue nell’interfaccia con il paziente.^[2594]

C.5 Gli strumenti digitali e l’intelligenza artificiale

Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, mai come sua sostituzione. Nel caso della Valle d’Aosta la telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti assumono un rilievo particolare, non disponibile in nessun’altra regione della serie nella stessa misura: la rete delle vallate laterali a popolazione dispersa e la stagionalità turistica, che concentra la popolazione nelle valli nei mesi invernali ed

estivi e la disperde nella bassa stagione, rendono la telepsicologia lo strumento principale per garantire la continuità del percorso nelle aree più remote e per assicurare la disponibilità del servizio anche nei periodi di bassa accessibilità fisica. La tabella seguente riepiloga funzioni e condizioni d'impiego.

Strumento o modalità	Funzione	Condizione d'impiego
Triage e screening assistiti	Indirizzamento e individuazione precoce	Sotto supervisione clinica
Supporto decisionale e sintesi clinica	Ausilio al professionista	Non vincolante
Riduzione del carico amministrativo	Automazione appropriata	Tempo restituito alla cura
Telepsicologia e telemonitoraggio	Accesso nelle vallate remote; continuità nelle stagionalità; bilingue a distanza	Complementare, non sostitutiva
Dispositivi terapeutici digitali	Intervento validato e prescritto	Conformi a dispositivo medico

Tabella C.3. Gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del servizio.

C.6 La formazione e le competenze

La sostenibilità del modello richiede un investimento formativo strutturato, articolato su quattro livelli. Il livello universitario opera attraverso i curricula e i tirocini, con attenzione alla collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta e con gli atenei piemontesi, che storicamente alimentano il bacino professionale regionale. Il livello post-universitario specialistico prevede una formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, comprensiva delle specificità del contesto valdostano: il disagio dell'anzianità, le problematiche connesse all'isolamento montano, le competenze bilingui italiano-francese. Il livello continuo prevede l'aggiornamento in servizio, l'audit clinico e la formazione a distanza. Il livello dell'affiancamento operativo garantisce il tutoraggio nelle prime settimane di servizio. A questi quattro livelli si aggiunge una componente trasversale sull'intelligenza artificiale. La Valle d'Aosta, pur piccola, dispone di un bacino professionale accessibile grazie alla prossimità ai grandi centri universitari del Piemonte.

Livello	Contenuto Soggetti e modalità	
1. Universitario	Curricula e tirocini nei percorsi di studio Università della Valle d'Aosta;	atenei piemontesi
2. Post-universitario specialistico	Psicologia delle cure primarie: modelli organizzativi, disagio dell'anzianità, isolamento montano, competenze bilingui (italiano-francese) Formazione dedicata;	Azienda USL Valle d'Aosta
3. Continuo (lavorativo)	Aggiornamento in servizio, audit clinico, revisione tra pari, formazione a distanza Educazione continua in medicina	
4. Affiancamento operativo	Tutoraggio sul campo nelle prime settimane e inserimento graduale Tutor aziendali; supervisione	
Componente IA (trasversale)	Selezione e uso degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti, conformità Moduli in tutti i livelli	

Tabella C.4. Il programma formativo a quattro livelli, con la componente trasversale sull'intelligenza artificiale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte D

Efficacia clinica ed evidenza

Metodo della revisione, evidenza di efficacia, qualità GRADE, benchmark internazionali, trasferibilità

Quarto dominio dell'HTA · l'efficacia clinica

Parte D — Efficacia clinica ed evidenza

Questa parte affronta il quarto dominio della valutazione, l'efficacia clinica, e ne ricostruisce la base di evidenza. Come per le regioni precedenti, il corpo dell'evidenza internazionale è invariante, poiché l'efficacia di un intervento clinico non muta con i confini regionali; muta invece la base di evidenza locale, dove la Valle d'Aosta parte da zero in assenza di qualunque forma di servizio. La parte espone il metodo della revisione e i risultati di efficacia (capitolo D.1); ne gradua la qualità e ne dichiara una cautela economica essenziale (D.2); presenta i benchmark internazionali (D.3); e discute le esperienze italiane, la trasferibilità e le condizioni locali (D.4).

D.1 Il metodo della revisione e l'evidenza di efficacia

La sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE. Il nucleo dell'evidenza proviene dal modello della cura collaborativa, di cui lo studio fondativo ha documentato che circa la metà dei pazienti trattati conseguiva una riduzione sostanziale dei sintomi a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura usuale.^[2595] La robustezza del risultato è confermata dalla meta-analisi su cinquantasette studi controllati, con un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a poco meno di un terzo di deviazione standard, e da una più recente revisione di quarantadue implementazioni, che documenta riduzioni rilevanti della depressione e dell'ansia e una

contrazione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri.^[2596] Sul versante dei dati reali, il programma inglese delle terapie psicologiche registra, su scala di oltre un milione di persone l’anno, un tasso di recupero del 50,2% e un miglioramento affidabile di oltre due terzi. Anche le sintesi più caute confermano un effetto di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante sull’intera popolazione.

D.2 La qualità dell’evidenza e una cautela economica

La graduazione della certezza secondo il sistema GRADE colloca l’efficacia clinica dell’integrazione psicologica nelle cure primarie su un livello da moderato a elevato per i disturbi comuni, mentre la certezza è più eterogenea e minore per gli esiti economici, in particolare per quelli di sistema. Da questa graduazione discende una cautela che lo studio adotta come principio di onestà intellettuale: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l’intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero.^[2597] Ciò significa che il valore economico del modello non può essere fondato sui risparmi sanitari diretti, ma poggia in misura preponderante sui ritorni sociali: una cautela che, lungi dall’indebolire il caso della Valle d’Aosta, ne corrobora la coerenza interna, poiché il caso economico della Valle d’Aosta è fondato anch’esso sulle ricadute sociali, e non su un risparmio diretto che il territorio non potrebbe rivendicare con certezza statistica.

D.3 I benchmark internazionali

L’evidenza si concretizza in quattro programmi nazionali consolidati, che costituiscono i riferimenti per il disegno del servizio. Il programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies) è il riferimento principale per l’organizzazione: servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell’ordine del 50% e monitoraggio degli esiti pressoché completo. Il modello olandese (POH-GGZ) integra una figura di supporto psicologico nello studio del medico di base, adottata dalla maggioranza dei medici, con ruolo complementare alla specialistica. Il modello australiano (Better Access), a invio esterno, ha innalzato di oltre dieci punti la quota di popolazione in trattamento. Il modello statunitense della cura collaborativa, validato da oltre novanta studi controllati, documenta riduzioni rilevanti della depressione e dei ricoveri.

Programma	Modello	Risultati principali
Regno Unito (NHS Talking Therapies)	Servizio integrato a intensità crescente	Recupero ~50%; monitoraggio esiti >98%; >1,3 milioni/anno
Paesi Bassi (POH-GGZ)	Supporto psicologico nello studio del medico di base	Adozione da ~tre quarti dei medici; ruolo complementare
Australia (Better Access)	Invio esterno a professionisti	Popolazione in trattamento dal 35% al 46%
Stati Uniti (Collaborative Care)	Équipe integrata con monitoraggio	Oltre 90 studi controllati; -47% depressione, -41% ricoveri

Tabella D.1. I benchmark internazionali dell’integrazione della salute mentale nelle cure primarie.

D.4 Le esperienze italiane, la trasferibilità e le condizioni locali

Sul piano nazionale, il quadro comprende i servizi avviati nelle regioni dotate di legge — fra cui la Campania, prima a istituire e attivare il servizio — e le esperienze pilota fondate su campioni limitati. La Valle d’Aosta, che non dispone di alcuna forma di psicologia territoriale di primo livello, parte da zero in assenza di qualunque

base di dati propri: lo studio si fonda interamente sui benchmark internazionali, con la consapevolezza che la trasposizione richiede validazione locale, evitando di trasferire meccanicamente le stime, soprattutto quelle economiche.^[2598] La condizione della Valle d'Aosta è dunque di impostare fin dall'avvio una rilevazione ben progettata, che consenta di generare dati propri man mano che il servizio si struttura a regime. Una precisazione di metodo accompagna l'intero studio: alcune cifre di larga circolazione — il rapporto di quattro a uno, l'affermazione per cui un euro ne genererebbe dieci — sono semplificazioni divulgative. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute,^[2599] e lo studio adotta prudenzialmente un rapporto beneficio-costi complessivo nell'ordine di 4,0-5,3 a uno, entro la banda Chisholm, per credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica regionale.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte E

Valutazione economica

Costo del servizio, risparmi diretti, ricadute sociali, saldo, costo-utilità e impatto sul bilancio

Quinto dominio dell'HTA · la valutazione economica

Parte E — Valutazione economica

Questa parte affronta il quinto dominio della valutazione, quello economico. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i valori, ancorati alla Valle d'Aosta. La parte definisce l'impianto e il costo del servizio (capitolo E.1); quantifica i risparmi diretti per il bilancio sanitario, canale per canale (E.2); stima le ricadute economico-sociali per la collettività (E.3); compone il quadro consolidato, con il saldo e il rapporto beneficio-costi, tenendo ferma la distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico (E.4); presenta l'analisi costo-utilità per paziente (E.5); e valuta l'impatto sul bilancio e la sostenibilità (E.6). Per la Valle d'Aosta il risultato si lascia anticipare in una formula: il caso finanziario diretto è di disavanzo lieve ma modestissimo nell'assoluto e agevolmente sostenibile a fronte dell'autonomia finanziaria, il caso economico complessivo è fortemente positivo, e il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali.

E.1 L'impianto e il costo del servizio

La valutazione economica impiega congiuntamente tre strumenti complementari — l'analisi costo-utilità, l'analisi di impatto sul bilancio e l'analisi del ritorno sociale — nella doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società. Il costo del servizio a regime assume un costo medio annuo per psicologo nell'ordine di 58.000-60.000 euro comprensivo degli oneri — riferimento elevato, coerente con il livello retributivo della Valle d'Aosta, simile a quello del Trentino-Alto Adige per il mercato del lavoro alpino — e ne deriva il costo totale del servizio nei tre scenari.^[2600] La tabella seguente riepiloga il costo del servizio per scenario.

Scenario	Psicologi	Costo annuo	Quota del FSR
Conservativo	~ 15	~ 1,5 milioni	~ 0,45%
Base	~ 22	~ 2,0 milioni	~ 0,60%
Espansivo	~ 30	~ 2,6 milioni	~ 0,78%

Tabella E.1. Il costo del servizio a regime nei tre scenari di copertura.

E.2 I risparmi diretti per il bilancio sanitario

I risparmi diretti per il bilancio sanitario si articolano in quattro canali. Il primo è la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, dell'ordine di 0,1, 0,2 e 0,3 milioni di euro l'anno nei tre scenari: in Valle d'Aosta gli accessi per cause psichiatriche sono amplificati dai trasferimenti dalle vallate, sicché ogni intercettazione precoce genera un risparmio di costo superiore alla media. Il secondo è la riduzione della spesa farmaceutica inappropriata, dell'ordine di 0,1, 0,2 e 0,3 milioni: la spesa farmaceutica valdostana è già inferiore alla media nazionale per i farmaci convenzionati,^[2601] ma mantiene margini di riduzione sul versante dei psicofarmaci prescritti in assenza di un supporto psicologico di primo livello. Il terzo, il più consistente, è la riduzione di ricoveri evitabili e di specialistica impropria, dell'ordine di 0,3, 0,5 e 0,8 milioni; il margine di recupero è più contenuto che nelle regioni sotto-finanziate, poiché il sistema è già ampiamente dotato. Il quarto, il recupero della mobilità, è per la Valle d'Aosta trascurabile, dell'ordine di 0,1-0,2 milioni nell'espansivo: il saldo di mobilità è lievemente negativo e di entità modesta, e la quota intercettabile con questo intervento è marginale.

^[2602] La somma dei quattro canali è dell'ordine di 0,7, 1,1 e 1,6 milioni di euro l'anno nei tre scenari.

Canale (milioni di euro l'anno)	Cons.	Base	Esp.
Accessi impropri al pronto soccorso	~ 0,1	~ 0,2	~ 0,3
Spesa farmaceutica inappropriata	~ 0,1	~ 0,2	~ 0,3
Ricoveri evitabili e specialistica	~ 0,3	~ 0,5	~ 0,8
Recupero della mobilità (frazione terr.le)	~ 0,1	~ 0,2	~ 0,2
Totale risparmi diretti	~ 0,7	~ 1,1	~ 1,6
Costo del servizio	~ 1,5	~ 2,0	~ 2,6
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -0,8	~ -0,9	~ -1,0

Tabella E.2. I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale e il saldo diretto.

E.3 Le ricadute economico-sociali

Oltre i confini del bilancio sanitario, l'intervento genera ricadute economico-sociali ampie, di cui la valutazione tiene conto nella prospettiva societale. Esse comprendono il recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo — con peso in un'economia montana a occupazione stabile e con redditi elevati — oltre al valore del benessere recuperato e al minor carico assistenziale sulle

famiglie. La componente del recupero dell’anzianità è peculiare alla Valle d’Aosta: con un indice di vecchiaia fra i più alti d’Italia e una quota di over-65 che raggiungerà il 34% nel 2040, la riduzione del carico dei caregiver familiari e il mantenimento dell’autonomia nelle persone anziane costituiscono una ricaduta di entità crescente, anche se di più difficile monetizzazione.^[2603] Le ricadute economico-sociali sono stimate, secondo i criteri prudenziali dello studio e nel rispetto della banda Chisholm 3,3-5,7:1,^[2604] nell’ordine di 4,5, 7,0 e 9,5 milioni di euro l’anno nei tre scenari. Sommate ai risparmi diretti, esse determinano un ritorno complessivo dell’ordine di 5,2, 8,1 e 11,1 milioni, e un saldo complessivo per la collettività ampiamente positivo. Ne discende un rapporto beneficio-costo complessivo dell’ordine di 4,0 a uno nello scenario conservativo, 4,8 a uno in quello di base e 5,3 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale adottata.

E.4 Il quadro consolidato: caso finanziario e caso economico

La composizione delle grandezze impone di tenere ferma la distinzione che governa l’intera lettura del caso della Valle d’Aosta. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di disavanzo lieve: in termini assoluti, il saldo è fra i più modesti della serie — meno di un milione di euro in qualunque scenario — perché la popolazione è molto piccola e il costo del servizio è corrispondentemente ridottissimo; il confronto con il Fondo sanitario regionale di circa 333 milioni mostra che si tratta di uno 0,3% della spesa sanitaria anche nello scenario espansivo, cifra agevolmente sostenibile. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. La tabella consolidata distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale.

Voce (milioni di euro l’anno)	Cons.	Base	Esp.
Costo del servizio	~ 1,5	~ 2,0	~ 2,6
Risparmi diretti (SSR)	~ 0,7	~ 1,1	~ 1,6
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -0,8	~ -0,9	~ -1,0
Ricadute economico-sociali	~ 4,5	~ 7,0	~ 9,5
Ritorno complessivo	~ 5,2	~ 8,1	~ 11,1
Saldo complessivo (caso economico)	~ +3,7	~ +6,1	~ +8,5
Rapporto beneficio-costo complessivo	~ 4,0:1	~ 4,8:1	~ 5,3:1

Tabella E.3. Il quadro economico consolidato, con la distinzione fra caso finanziario e caso economico.

E.5 L’analisi costo-utilità per paziente

Accanto alle grandezze aggregate, la valutazione conduce un’analisi costo-utilità per paziente trattato, mediante un modello di Markov a cinque anni con sconto del 3%, indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. Il costo atteso per paziente nel braccio dell’intervento è dell’ordine di 2.495 euro, contro 3.799 del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L’intervento è quindi dominante: a un tempo meno costoso e più efficace.^[2605] L’analisi di sensibilità probabilistica, su diecimila simulazioni, conferma la solidità del risultato: l’intervento è costo-efficace nell’88,9% dei casi alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell’84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell’ordine di 7.815 euro.

Grandezza (per paziente)	Comparatore	Intervento	Differenza
Costo atteso per paziente	~ 3.799 euro	~ 2.495 euro	– 1.304 euro
Anni di vita ponderati (QALY)	3,392	3,627	+ 0,236
Esito	—	—	Intervento dominante
Costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	—	—	88,9% delle simulazioni

Tabella E.4. L'analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni).

E.6 L'impatto sul bilancio, la sostenibilità e la lacuna dei dati

Sul piano dell'impatto sul bilancio, il costo del servizio a regime rappresenta una quota dell'ordine dello 0,45-0,78% del Fondo sanitario regionale, che si configura come la più favorevole della serie in termini di incidenza percentuale: la Valle d'Aosta, pur con la spesa pro-capite più elevata, ha un fondo assoluto ridotto e un costo del servizio corrispondentemente contenuto, e finanzia integralmente la sanità con le risorse proprie trattenute sul territorio, senza apporto a carico dello Stato, con bilanci in equilibrio.^[2606] Il costo annuo del servizio nell'intero scenario espansivo — meno di tre milioni di euro — è di entità tale da essere finanziabile con variazioni di bilancio marginali. Resta da dichiarare con franchezza la lacuna dei dati: le grandezze economiche sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti certificati dell'Azienda USL; la Valle d'Aosta parte da zero e non dispone di dati propri sul servizio, sicché l'estrazione dei conti certificati e l'impostazione di una rilevazione ben progettata dall'avvio del servizio sono la priorità da completare prima della presentazione esterna. La sintesi è univoca: il caso diretto è prudente e in disavanzo modestissimo, sostenibile a fronte dell'autonomia finanziaria; il caso sociale è robusto e fortemente positivo; il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte F

Modellazione e incertezza

Modello decisionale, sensibilità deterministica e probabilistica, scenari, verifica empirica e valore dell'informazione

Quinto dominio dell'HTA · la robustezza della valutazione economica

Parte F — Modellazione e incertezza

Questa parte completa il dominio economico sottoponendo i risultati della Parte E alla prova della modellazione e dell'incertezza. Come per le altre regioni, il modello è invariante e muta solo ciò che attiene alla verifica empirica locale. La parte descrive il modello decisionale e i suoi parametri (capitolo F.1); ne saggia la robustezza con l'analisi di sensibilità deterministica (F.2) e probabilistica (F.3); ne esplora gli scenari di copertura (F.4); e definisce il disegno della verifica empirica e il valore dell'informazione (F.5). Per la Valle

d’Aosta questo ultimo capitolo assume un carattere prospettico: poiché il servizio non esiste, non vi è base di dati locale su cui fondare la stima, e il disegno della verifica empirica è la condizione per generare dati propri fin dall’avvio.

F.1 Il modello decisionale e i suoi parametri

Poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l’orizzonte direttamente osservabile, lo studio li proietta nel tempo mediante un modello decisionale, e ne rende esplicite le assunzioni.^[2607] La storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%.^[2608] A ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita, trattati come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l’incertezza. Nel caso base l’intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell’ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità. La tabella seguente riepiloga i parametri principali del modello.

Parametro del modello	Valore
Stati clinici	Benessere o sottosoglia, episodio, cronicità, recupero
Orizzonte temporale	Cinque anni, con cicli successivi
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti
Costo per ciclo (recupero)	~ 40 euro
Costo per ciclo (cronicità)	~ 700 euro
Costo dell’intervento	~ 300 euro una tantum
Trattamento dell’incertezza	Parametri come distribuzioni di probabilità

Tabella F.1. I parametri principali del modello di Markov (comune a tutti gli studi della serie).

F.2 L’analisi di sensibilità deterministica

La robustezza del risultato è saggiata variando un parametro per volta entro intervalli plausibili. La variazione dei parametri più influenti — l’efficacia dell’intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — non muta il segno del risultato, che resta favorevole all’intervento in tutti i casi esaminati.^[2609] L’ordinamento dei parametri per influenza mostra che l’esito è più sensibile all’efficacia clinica e al costo evitato della cronicità, e meno agli altri parametri; ciò orienta le priorità di raccolta dei dati verso le grandezze più influenti, che per la Valle d’Aosta sono da stimare interamente su base locale, non disponendo di alcun dato pregresso.

F.3 L’analisi di sensibilità probabilistica

In seconda istanza, la robustezza è saggiata facendo variare simultaneamente tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni, su diecimila simulazioni. L’intervento risulta costo-efficace nell’88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell’84,6%, con un

beneficio monetario netto medio per paziente dell’ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro.^[2610] La curva di accettabilità conferma che alla soglia convenzionale la probabilità di convenienza è prossima al 90% e cresce per soglie superiori.

Esito della sensibilità probabilistica	Valore
Probabilità di costo-efficacia (soglia 30.000 euro/QALY)	88,9% delle simulazioni
Probabilità di dominanza	84,6% delle simulazioni
Beneficio monetario netto medio per paziente	~ 7.815 euro
Intervallo di confidenza al 95%	da ~ -5.736 a ~ +21.501 euro
Numero di simulazioni	10.000

Tabella F.2. Gli esiti dell’analisi di sensibilità probabilistica (per paziente).

F.4 Gli scenari di copertura e l’incertezza aggregata

Gli scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno. Per la Valle d’Aosta, data la dimensione molto ridotta, anche lo scenario conservativo (15 psicologi) rappresenta un primo passo sostanziale rispetto all’assenza attuale. Va ribadita una distinzione di onestà analitica: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un’incertezza maggiore; lo studio la riconosce e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi.^[2611]

F.5 La verifica empirica e il valore dell’informazione

Il disegno della verifica empirica costituisce, per la Valle d’Aosta, un elemento di impostazione fondamentale. A differenza delle regioni che dispongono di assetti già operanti, la Valle d’Aosta parte da zero e deve costruire la propria base di dati ex novo. Questo, lungi dall’essere un limite, è un’opportunità: impostare fin dall’avvio del servizio una rilevazione ben progettata, con raccolta sistematica dei dati di processo e di esito secondo il dataset minimo definito in Appendice B, consente di generare dati propri che sostituiranno progressivamente le stime derivate dai benchmark.^[2612] Il disegno controfattuale più appropriato per la Valle d’Aosta è l’attivazione graduale per distretto, con i distretti attivati successivamente che fungono da controllo per quelli già avviati.^[2613] L’analisi del valore dell’informazione indica che il beneficio di ridurre l’incertezza, anche alla piccola scala della Valle d’Aosta, eccede ampiamente il costo di una raccolta dati ben organizzata.^[2614]

Priorità di ricerca	Finalità	Rilevanza
Conti certificati dell’Azienda USL Valle d’Aosta	Sostituire le stime per quota con dati reali	Massima
Impostazione del dataset minimo dall’avvio	Generare dati propri su processo ed esiti	Massima
Tassi di intercettazione e costi evitati	Ridurre l’incertezza sulle grandezze aggregate	Alta
Efficacia clinica nel contesto locale	Corroborare il parametro più influente	Alta

Tabella F.3. Le priorità di ricerca derivanti dall'analisi del valore dell'informazione.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte G

Equità e impatto distributivo

Gradiente sociale, assi territoriali del divario, barriere di accesso, costo-efficacia distributiva

Dominio dell'HTA · i pazienti e l'equità

Parte G — Equità e impatto distributivo

Questa parte affronta il dominio dell'equità, che la valutazione di tecnologia sanitaria tiene distinto dall'efficienza. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i dati distributivi, ancorati alla Valle d'Aosta. La parte definisce il quadro dell'equità e il gradiente sociale (capitolo G.1); analizza gli assi territoriali del divario e le barriere di accesso (G.2); descrive gli strumenti attraverso cui il servizio agisce sull'equità (G.3); e presenta l'analisi di costo-efficacia distributiva con le sue implicazioni allocative (G.4). Il tratto distintivo della Valle d'Aosta è la compresenza di un divario territoriale particolarmente marcato — fondovalle centrale e capoluogo contro vallate laterali a popolazione anziana e dispersa — e di un elemento di bilinguismo strutturale, cui si aggiunge la dimensione dell'invecchiamento come asse di bisogno crescente.

G.1 Il quadro dell'equità e il gradiente sociale

L'analisi distributiva costituisce un dominio proprio della valutazione, poiché un intervento efficiente nel complesso può nondimeno accrescere o ridurre le disuguaglianze.^[2615] Il punto di partenza è il gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori.^[2616] In Valle d'Aosta, a questo gradiente si sommano barriere di accesso geografiche, linguistiche e culturali, oltre allo stigma. Sul piano geografico, le vallate laterali sono penalizzate dalle distanze e dall'orografia, con costi di accesso fisico al servizio molto più elevati che nel fondovalle. Sul piano linguistico, il servizio deve essere disponibile in entrambe le lingue ufficiali — italiano e francese — per garantire un accesso effettivo a tutti i residenti.^[2617] Sul piano generazionale, la componente anziana presenta bisogni propri che richiedono competenze specifiche e un'organizzazione dell'accesso adatta alle limitazioni fisiche.

G.2 Gli assi del divario territoriale

La specificità distributiva della Valle d'Aosta risiede nella struttura del divario territoriale, particolarmente pronunciata in ragione della morfologia alpina. Il primo asse separa il fondovalle centrale e il capoluogo Aosta — dove si concentrano i servizi, le infrastrutture e la maggior parte della popolazione — dalle vallate laterali (Valle di Cogne, Valle del Gran San Bernardo, Valle di La Thuile, Valle del Cervino, Valle di Gressoney, Valle del Champorcher, ecc.), dove la dispersione abitativa e le distanze dall'asse principale rendono l'accesso ai servizi significativamente più oneroso e selettivo. Il secondo asse, meno visibile ma strutturale, è quello dell'invecchiamento: le vallate laterali presentano spesso una struttura demografica più anziana della media regionale già elevata, combinando il doppio svantaggio del bisogno maggiore e dell'accesso più difficile. La tabella seguente sintetizza gli assi e le leve di riequilibrio.

Asse del divario	Caratterizzazione	Leva di riequilibrio
Fondovalle / vallate lat.	Vallate a popolazione dispersa, distante dai centri, con orografia che ostacola l'accesso T	elepsicologia assistita; presenze programmate nei poliambulatori distrettuali delle vallate
Bilinguismo strutturale	Italiano e francese, con tutela costituzionale; accesso effettivo richiede il servizio nella lingua del res	idente Personale bilingue; disponibilità in francese; telepsicologia bilingue
Anzianità crescente	Indice di vecchiaia 215,1; over-65 al 34% nel 2040; bisogno crescente e accesso più difficoltoso per limita	zioni fisiche Intercettazione tramite MMG; domiciliarietà; programmi specifici per l'anzianità

Tabella G.1. Gli assi del divario territoriale e bilingue della Valle d'Aosta, la dimensione dell'anzianità e le leve di riequilibrio.

G.3 Gli strumenti dell'equità

Il servizio agisce sull'equità attraverso meccanismi precisi.^[2618] La prossimità nelle Case della Comunità e nei poliambulatori distrettuali abbate parte delle barriere geografiche e indirizza l'offerta verso chi ne è oggi escluso; in Valle d'Aosta il pieno effetto pro-equità opera attraverso la prossimità nelle vallate, l'erogazione bilingue e una programmazione dell'accesso che non penalizzi i residenti nelle aree più remote. La telepsicologia assistita avvicina l'offerta alle vallate alpine a popolazione dispersa e consente di mettere a disposizione, anche a distanza, personale bilingue, in funzione complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, estendendo la copertura proprio dove l'accesso è più difficile.^[2619] L'attenzione specifica al bisogno dell'anzianità — programmazione compatibile con le limitazioni di mobilità, disponibilità di accesso domiciliare o di trasporto assistito, formazione specifica degli psicologi — assicura che il servizio raggiunga la fascia di età a più elevato bisogno non soddisfatto.^[2620]

G.4 La costo-efficacia distributiva e le implicazioni allocative

L'analisi di costo-efficacia distributiva indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, poiché i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto.^[2621] Perché questo potenziale si realizzi, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle vallate più isolate e garantendo la disponibilità bilingue del servizio. Un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari; un'allocazione ponderata per il bisogno e per la distanza li riduce. Va tenuto presente il rischio di iniquità inversa: se l'istituzione del servizio privilegiasse, per facilità organizzativa, il solo capoluogo o il solo fondovalle, l'effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell'allocazione delle ore di servizio fra i distretti, assicurando la copertura delle vallate e la disponibilità bilingue fin dall'avvio.^[2622]

Dimensione distributiva	Esito per la Valle d'Aosta
Efficienza complessiva	Intervento costo-efficace e dominante per paziente
Direzione dell'effetto distributivo	Favorevole all'equità: maggiori benefici nei gruppi a più alto bisogno
Condizione di realizzazione	Allocazione pro-equità verso le vallate e bilinguismo italiano-francese dall'avvio; attenzione all'anzianità
Strumenti abilitanti	Prossimità distrettuale, telepsicologia bilingue, programmazione per l'anzianità, accesso domiciliare-assistito
Rischio da prevenire	Iniquità inversa se il servizio è concentrato nel solo fondovalle di Aosta

Tabella G.2. L'impatto distributivo atteso dell'intervento e le sue condizioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte H

Profili etico, giuridico e organizzativo

Competenza e forma dell'atto, rapporto di lavoro, governance, tutele etiche e protezione dei dati

Domini dell'HTA · aspetti giuridici, etici e organizzativi

Parte H — Profili etico, giuridico e organizzativo

Questa parte affronta congiuntamente i domini giuridico, organizzativo ed etico. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto. La parte tratta il profilo giuridico (capitolo H.1); il profilo organizzativo e la governance (H.2); il profilo etico (H.3); e la sintesi dei tre profili (H.4). Il tratto distintivo della Valle d'Aosta emerge sul piano giuridico: la materia sanitaria è di piena competenza regionale in forza dello statuto speciale; nessuna norma ha finora istituito il servizio; e la condizione abilitante è l'approvazione di una legge regionale o di un atto di programmazione della Giunta che fissi il modello, l'organizzazione e il finanziamento.

H.1 Il profilo giuridico

La fattibilità dell'intervento dipende dal presidio congiunto dei tre profili, una debolezza in uno solo dei quali ne comprometterebbe l'esito.^[2623] Sul piano giuridico, la materia sanitaria è attribuita alla Regione autonoma Valle d'Aosta in forza dello statuto speciale, con una competenza legislativa esclusiva più ampia di quella delle regioni ordinarie. La sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — originata dal giudizio sulla legge campana, di cui ha riconosciuto la legittimità — conferma la possibilità per le regioni di disciplinare il servizio nel rispetto dei principi statali: a fortiori, la Valle d'Aosta, dotata di statuto speciale, ha pieno titolo a legiferare in materia. La decisione giuridica rilevante è l'approvazione di una legge regionale o di un atto deliberativo della Giunta che istituisca il servizio, ne fissi il modello organizzativo, il rapporto di lavoro degli psicologi (pubblico dipendente o convenzionato con l'Azienda USL), le modalità di accesso (gratuito, con ticket, con esenzioni per le fasce protette) e il finanziamento.^[2624] Quanto ai livelli essenziali di assistenza, la psicologia

delle cure primarie non vi è ancora ricompresa; la Valle d'Aosta finanzia integralmente la sanità con le risorse proprie, senza apporto statale, sicché il finanziamento del servizio è disponibile entro l'autonomia regionale. [2625]

Profilo giuridico	Contenuto per la Valle d'Aosta
Competenza	Regionale esclusiva in forza dello statuto speciale; Corte Cost. 241/2021 (legge campana) conferma il titolo a disciplinare
Forma dell'atto	Legge regionale o atto di programmazione della Giunta regionale; nessuna norma esistente; da istituire ex novo
Rapporto di lavoro	Da definire: pubblico dipendente dell'Azienda USL o convenzionato; scelta da fissare nel provvedimento istitutivo
Livelli essenziali di assistenza	Non ancora ricompresi; autofinanziamento regionale integrale; copertura disponibile entro l'autonomia regionale
Cornice territoriale	Decreto Ministeriale 77/2022; inserimento nelle Case della Comunità e nei poliambulatori distrettuali dell'Azienda USL
Rapporto con i servizi specialistici	Integrazione con i Centri di Salute Mentale e con il Servizio di Psichiatria del Presidio Parini, che il servizio precede e alleggerisce

Tabella H.1. I profili giuridici del servizio nella Valle d'Aosta.

H.2 Il profilo organizzativo e la governance

Sul piano organizzativo, l'istituzione del servizio in Valle d'Aosta presenta una condizione di semplicità strutturale che non ha eguali nella serie: l'unica azienda sanitaria regionale — l'Azienda USL Valle d'Aosta — è l'unico soggetto attuatore, non vi sono frammentazioni fra aziende, non vi sono competenze concorrenti da armonizzare. La sfida organizzativa principale è invece territoriale: garantire la copertura equa dei quattro distretti e delle vallate laterali su un territorio integralmente montano, con particolare attenzione all'accesso nelle aree più remote e al bilinguismo del servizio. [2626] La sede di governance è naturalmente quella regionale — Assessorato alla salute, Azienda USL, Ordine degli Psicologi, rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta — a cui spetta definire il modello, approvare il disciplinare di servizio, avviare il reclutamento e impostare il sistema di monitoraggio. La tabella seguente sintetizza l'assetto organizzativo.

Elemento organizzativo	Assetto per la Valle d'Aosta
Articolazione del sistema	Azienda USL Valle d'Aosta (unica); quattro distretti sanitari su territorio montano; Ospedale Parini presidio principale
Coordinamento	Assessorato alla salute, Azienda USL, Ordine degli Psicologi; governance semplificata dall'unicità dell'azienda sanitaria
Sfida organizzativa	Copertura equa dei quattro distretti e delle vallate; bilinguismo italiano-francese; accesso nelle aree più remote; anzianità crescente
Regia dell'istituzione	Legge o atto regionale; disciplinare di servizio; reclutamento; sistema informativo dall'avvio
Soggetti coinvolti	Regione, Azienda USL, Ordine degli Psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, Università della Valle d'Aosta

Tabella H.2. L'assetto organizzativo e la governance dell'istituzione.

H.3 Il profilo etico

Sul piano etico, lo studio adotta cautele a tutela dei pazienti. Le situazioni che coinvolgono minori e persone vulnerabili — e in Valle d'Aosta la quota di anziani vulnerabili è particolarmente rilevante — sono presidiate impiegando gli strumenti di esito nei soli punteggi complessivi e indirizzando le situazioni di rischio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza entrare nel merito dei metodi clinici.^[2627] L'intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un'informazione chiara nelle due lingue ufficiali sulle finalità e sui limiti del trattamento. Gli strumenti di intelligenza artificiale sono concepiti come ausilio del clinico, conformi al quadro europeo e ai requisiti sui dispositivi medici, e la responsabilità delle decisioni cliniche resta interamente in capo al professionista.^[2628]

H.4 Sintesi dei profili

La ricognizione dei tre profili conduce a una conclusione netta: il profilo giuridico, quello organizzativo e quello etico sono tutti presidabili, e la condizione abilitante dell'intervento è, per la Valle d'Aosta, l'approvazione di un atto normativo o programmatico regionale che istituisca il servizio ex novo, agevolata dalla piena autonomia finanziaria e dall'unicità dell'azienda sanitaria attuatrice. È questo il passaggio da cui dipende la piena operatività del servizio.^[2629] Definiti i profili, la parte che segue affronta l'attuazione, la fattibilità e la sostenibilità.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte I

Attuazione, fattibilità e sostenibilità

I cinque casi, il dimensionamento, le fasi di attuazione, i rischi e le mitigazioni

Five Case Model · la realizzabilità della decisione

Parte I — Attuazione, fattibilità e sostenibilità

Questa parte affronta l’attuazione, la fattibilità e la sostenibilità dell’intervento, organizzandole secondo il modello a cinque casi della decisione di investimento pubblico. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e mutano gli elementi di contesto. La parte espone i cinque casi (capitolo I.1); definisce il dimensionamento e le fasi di attuazione (I.2); tratta il reclutamento, la formazione e il cronoprogramma (I.3); analizza la sostenibilità finanziaria e organizzativa (I.4); e individua i rischi e le mitigazioni (I.5). Il tratto distintivo della Valle d’Aosta è che l’attuazione parte da zero, in un territorio piccolo con un’unica azienda sanitaria e una piena autonomia finanziaria: condizioni che rendono la fattibilità concreta e l’attuazione più semplice che nella maggior parte delle regioni della serie, pur nella sfida dell’accessibilità territoriale e del bilinguismo.

I.1 I cinque casi della decisione

Lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi.^[2630] Il caso strategico è solido: l’istituzione del servizio è coerente con il DM 77/2022, con le Case della Comunità e con la programmazione regionale di salute mentale, e risponde a un bisogno reale di intercettazione del disagio psichico comune in una regione a indice di vecchiaia molto elevato e a popolazione dispersa nelle vallate.^[2631] Il caso economico rinvia ai risultati già esposti, nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di disavanzo modestissimo, sostenibile a fronte dell’autonomia, e un caso sociale fortemente positivo.^[2632] Il caso commerciale si avvale di un bacino professionale accessibile grazie alla vicinanza ai grandi centri universitari del Piemonte, con possibilità di reclutare psicologi bilingui italiano-francese anche dalla Svizzera romanda e dalla Francia confinante, in ragione della collocazione geografica della regione.^[2633] Il caso finanziario è il più favorevole della serie in assoluto: un costo annuo che non supera i tre milioni di euro nello scenario espansivo, pari allo 0,78% del Fondo sanitario regionale, disponibile integralmente entro l’autonomia finanziaria regionale.^[2634] Il caso gestionale è semplificato dall’unicità dell’azienda sanitaria regionale, che evita le frammentazioni operative tipiche delle regioni con più aziende.^[2635]

Caso	Contenuto per la Valle d’Aosta
Strategico	Coerenza con DM 77/2022, Case della Comunità, programmazione salute mentale; risposta al bisogno in una regione molto anziana e a popolazione montana dispersa
Economico	Rapporto beneficio-costi 4,0-5,3 a uno; dominanza per paziente; caso sociale fortemente positivo
Commerciale	Bacino negli atenei piemontesi; possibilità di reclutamento bilingue da Svizzera romanda e Francia; mercato del lavoro favorevole per una piccola dotazione
Finanziario	Costo 0,45-0,78% del FSR; autofinanziamento integrale con le risorse proprie; nessun apporto statale richiesto; copertura disponibile entro l’autonomia regionale
Gestionale	Unica azienda sanitaria (Azienda USL); governance semplificata; quattro distretti attuatori; Assessorato regionale alla salute come regia

Tabella I.1. I cinque casi della decisione di investimento pubblico.

I.2 Il dimensionamento e le fasi di attuazione

Il servizio va istituito ex novo, dimensionando la dotazione iniziale sul numero di psicologi coerente con lo scenario conservativo e procedendo per gradi verso gli scenari di maggiore copertura; il fabbisogno a regime è stimato nell'ordine di 30 psicologi nello scenario espansivo, 22 in quello di base e 15 in quello conservativo.

^[2636] L'attuazione si articola in tre fasi: una fase di istituzione, nella quale vengono approvato l'atto normativo o programmatico, definito il disciplinare di servizio e avviato il reclutamento; una fase di avvio, nella quale il servizio viene attivato nel capoluogo e nelle sedi distrettuali, con priorità alla copertura del Distretto 2 (Aosta) e progressiva estensione agli altri distretti; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato e la copertura delle vallate è assicurata anche mediante la telepsicologia assistita. La tabella seguente riepiloga le fasi.

Fase	Contenuto	Dimensionamento indicativo
Istituzione	Atto normativo/programmatico, disciplinare, reclutamento	Avvio reclutamento primo nucleo
Avvio	Attivazione in Aosta e nelle sedi distrettuali	~ 10-15 psicologi (scenario conservativo)
Regime	Copertura piena, anche via telepsicologia nelle vallate	fino a ~ 22-30 psicologi

Tabella I.2. Le fasi di attuazione e il dimensionamento progressivo.

I.3 Reclutamento, formazione e cronoprogramma

Il reclutamento degli psicologi si avvale del bacino professionale piemontese, con possibilità di attrattiva per professionisti bilingui provenienti dalla Svizzera romanda e dalla Francia; la dotazione ridotta — quindici psicologi nello scenario iniziale — è di entità tale da consentire il reclutamento in tempi brevi, entro un anno dall'approvazione dell'atto istitutivo. La formazione dedicata, secondo il programma a quattro livelli definito nella Parte C, comprende le specificità del contesto valdostano: il disagio dell'anzianità, l'isolamento montano, il bilinguismo italiano-francese.^[2637] Il cronoprogramma si sviluppa su un orizzonte biennale per il raggiungimento del regime nello scenario conservativo, con la strutturazione della telepsicologia nelle vallate come componente aggiuntiva da attivare nella fase successiva.^[2638]

I.4 La sostenibilità finanziaria e organizzativa

La sostenibilità finanziaria della Valle d'Aosta è, in termini relativi, la più favorevole della serie: il costo del servizio a regime è di entità così ridotta — meno di tre milioni nell'espansivo — che è finanziabile con variazioni di bilancio marginali, all'interno di un fondo sanitario regionale di oltre 330 milioni gestito in regime di piena autonomia finanziaria.^[2639] La sostenibilità organizzativa dipende dalla capacità dell'Azienda USL di gestire un servizio nuovo su un territorio montano con vincoli di accessibilità, dalla disponibilità di personale bilingue e dalla strutturazione di un sistema informativo adeguato dall'avvio.^[2640] L'avanzamento è seguito mediante gli indicatori definiti in Appendice C.

I.5 I rischi e le mitigazioni

L'attuazione presenta rischi propri della posizione della Valle d'Aosta: la difficoltà di garantire la copertura equa delle vallate su un territorio montano a bassissima densità; il rischio che il servizio si concentri nel solo fondovalle di Aosta, creando iniquità inversa; la difficoltà di reclutare personale bilingue disposto a risiedere in

una regione piccola e cara; e la mancanza di una base di dati propri che rende le stime più incerte che nelle regioni già avviate.^[2641] Tali rischi sono fronteggiati con una pianificazione esplicita della copertura distrettuale dall’avvio, con l’incentivazione del bilinguismo nel reclutamento, con la telepsicologia come strumento di copertura complementare nelle vallate più remote, e con l’impostazione sistematica del dataset minimo dall’avvio del servizio. La tabella seguente riepiloga i rischi e le mitigazioni.

Rischio	Mitigazione
Concentrazione nel solo fondovalle (rischio iniquità inversa)	Allocazione esplicita pro-equità fra i distretti; telepsicologia per le vallate
Difficoltà di reclutamento bilingue italiano-francese	Incentivi per personale bilingue; reclutamento dalla Svizzera romanda e dalla Francia confinante
Mancanza di base dati propri (incertezza delle stime)	Dataset minimo strutturato dall’avvio; raccolta sistematica dei conti Azienda USL
Rischio di cronicizzazione a costo elevato (anzianità)	Protocolli di invio al CSM; criteri espliciti di passaggio di livello; formazione specifica

Tabella I.3. I rischi dell’attuazione e le relative mitigazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE ·
APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte L

Monitoraggio e valutazione ex post

Disegno controfattuale prospettico, batteria di indicatori, cruscotto regionale e clausola valutativa

Inferenza causale quasi-sperimentale · la valutazione ex post

Parte L — Monitoraggio e valutazione ex post

Questa parte definisce il sistema di monitoraggio e la valutazione ex post dell’intervento. Come per le altre regioni, l’impianto è invariante e muta ciò che attiene al disegno valutativo locale. La parte espone le finalità e l’impianto della valutazione (capitolo L.1); il disegno controfattuale e i metodi di stima (L.2); la batteria degli indicatori (L.3); il cruscotto di monitoraggio e la clausola valutativa (L.4); e la sintesi (L.5). Il tratto distintivo della Valle d’Aosta è che il servizio non esiste, e che il sistema di monitoraggio va costruito ex novo dall’avvio: ciò impone una progettazione attenta del dataset minimo e della clausola valutativa, ma offre l’opportunità di impostare la rilevazione nel modo più adeguato fin dal principio.

L.1 Finalità e impianto della valutazione

Il monitoraggio e la valutazione ex post servono a rendere conto dell’impiego delle risorse, ad apprendere dall’esperienza e a correggere il corso dell’attuazione; non sono un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l’istituzione del servizio diventa apprendimento istituzionale, ancorato a una clausola valutativa.

[2642] L'impianto distingue i tre livelli della struttura, del processo e dell'esito, in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti.

L.2 Il disegno controfattuale e i metodi

Il disegno della valutazione d'impatto costituisce, per la Valle d'Aosta, un punto da costruire con cura. Poiché il servizio è attivato ex novo, non vi è una linea di base propria, e il disegno controfattuale deve appoggiarsi su due strategie complementari. [2643] La prima è l'attivazione graduale per distretto, nella quale l'avvio sfalsato fra i quattro distretti consente di stimare l'effetto con il metodo della differenza-nelle-differenze, con i distretti non ancora attivati che fungono da confronto per quelli già avviati; questa strategia è particolarmente appropriata per la Valle d'Aosta, data la chiarezza dei confini distrettuali e la comparabilità fra i territori. [2644] La seconda è il confronto con i dati pre-istituzione, disponibili dai sistemi informativi dell'Azienda USL per le grandezze di sistema (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri), che consentono di documentare l'effetto pre-post. [2645] L'effetto causale sull'intera regione è infine stimato, in prospettiva, con il controllo sintetico rispetto a un gruppo di confronto costruito con le regioni vicine.

L.3 La batteria degli indicatori

Il servizio è osservato attraverso una batteria di indicatori organizzata per categorie. Gli indicatori di struttura misurano la capacità installata — sedi, incarichi, ore, dotazione, copertura per distretto. [2646] Gli indicatori di processo misurano il funzionamento — prese in carico, attesa al primo colloquio, colloqui per persona, tasso di invio appropriato ai CSM. [2647] Gli indicatori di esito clinico misurano il beneficio diretto — miglioramento, recupero, remissione. [2648] Gli indicatori di esito di sistema misurano l'effetto sul resto del sistema — accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche, psicofarmaci, ricoveri evitabili. [2649] Gli indicatori economici consentono di verificare ex post le stime e di sostituire i valori ricostruiti con quelli effettivi. [2650] Gli indicatori di equità, disaggregati per distretto e per vallata, per fasce di età e per lingua, verificano che il servizio riduca i divari fra fondovalle e vallate e garantisca la disponibilità bilingue. [2651] La tabella seguente riepiloga le categorie.

Categoria	Contenuto (dell'ordine di 55 indicatori complessivi)
Struttura	Sedi attivate per distretto, incarichi, ore, dotazione, copertura del fabbisogno
Processo	Prese in carico, attesa al primo colloquio, colloqui per persona, invio appropriato ai CSM
Esito clinico	Miglioramento, recupero, remissione (PHQ-9, GAD-7, punteggi complessivi)
Esito di sistema	Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche, psicofarmaci, ricoveri evitabili, specialistica impropria
Economici	Costo, risparmi diretti, ricadute sociali, rapporto beneficio-costi su dati reali
Equità	Copertura e accesso per distretto e vallata, per fasce di età (anziani), per lingua (italiano/francese)
Qualità	Soddisfazione, appropriatezza, continuità del rapporto clinico

Tabella L.1. Le sette categorie della batteria di indicatori.

L.4 Il cruscotto regionale e la clausola valutativa

Gli indicatori confluiscono in un cruscotto di monitoraggio aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; la titolarità del cruscotto è dell'Azienda USL Valle d'Aosta, in raccordo con l'Assessorato regionale alla salute, che ne assicura l'alimentazione sistematica. Lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa: il provvedimento istitutivo del servizio — legge regionale o deliberazione della Giunta — deve corredare l'istituzione di una clausola valutativa che impegni la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati del servizio, con la documentazione dell'efficacia, dei costi e dell'equità. La raccolta dei dati poggia sul sistema informativo dell'Azienda USL, da impostare in forma comparabile con gli standard nazionali e interoperabile con il fascicolo sanitario elettronico regionale. La valutazione si articola in un monitoraggio in itinere, che accompagna l'attivazione progressiva, e in una valutazione ex post a regime.

Elemento della governance valutativa	Scelta per la Valle d'Aosta
Disegno d'impatto	Attivazione graduale per distretto (differenza-nelle-differenze); confronto pre-post; controllo sintetico prospettico
Linea di base	Dati dai sistemi informativi Azienda USL (pronto soccorso, farmaceutica, ricoveri) pre-istituzione; assenza di dati clinici propri
Titolarità del cruscotto	Azienda USL Valle d'Aosta, in raccordo con l'Assessorato alla salute
Clausola valutativa	Da corredare all'atto istitutivo; relazione periodica al Consiglio regionale; disaggregata per distretto e per lingua
Flusso informativo	Sistema informativo Azienda USL; dataset minimo strutturato dall'avvio; interoperabile con FSE regionale
Tempi	In itinere (accompagnamento dell'avvio) ed ex post (effetto a regime, dall'anno terzo-quinto)

Tabella L.2. La governance della valutazione e il cruscotto regionale.

L.5 Sintesi del monitoraggio

La valutazione è la condizione per trasformare l'istituzione del servizio in apprendimento, e la Valle d'Aosta, pur partendo da zero, dispone dell'opportunità — propria di chi inizia — di impostare la rilevazione nel modo più adeguato fin dal principio; perché ciò si realizzi, occorre corredare l'atto istitutivo di una clausola valutativa vincolante e impostare il dataset minimo dall'avvio del servizio, secondo le specifiche dell'Appendice B. Definito il sistema di monitoraggio, la parte conclusiva compone i risultati dei diversi domini in una sintesi multidimensionale e formula le raccomandazioni.

STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE · APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Parte M

Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Parte M — Sintesi multidimensionale e raccomandazioni

Questa parte conclude lo studio componendo i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo e traducendolo in raccomandazioni operative. Come per le altre regioni, l'impianto è invariante e mutano i contenuti, ancorati alla Valle d'Aosta. La parte richiama la sintesi per dominio (capitolo M.1); espone l'analisi multi-criterio (M.2); formula la raccomandazione principale e il dimensionamento (M.3); ne precisa le condizioni e la lacuna da colmare (M.4); e chiude con la collocazione nella serie e la conclusione (M.5). Il tratto distintivo della Valle d'Aosta percorre l'intera sintesi: è la più piccola regione italiana, alpina, bilingue, a piena autonomia finanziaria, con un indice di vecchiaia fra i più alti d'Italia, priva di qualunque forma di psicologo di base, chiamata a istituire per la prima volta un servizio con un costo contenutissimo in valore assoluto ma un ritorno sociale nettamente positivo.

M.1 La sintesi per dominio

Il quadro che emerge dai domini è coerente: il bisogno è ampio per la prevalenza dell'anzianità e dell'isolamento nelle vallate, con un tasso di incidenza dei casi trattati di salute mentale (118,5/10.000) molto superiore alla media nazionale (55,4/10.000), indicatore di un sistema attivo ma che non intercetta il bisogno di primo livello; l'efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida, anche se la certezza locale parte da zero; il quadro economico distingue un caso finanziario di disavanzo modestissimo in valore assoluto da un caso sociale fortemente positivo; l'equità è favorevole se la copertura è allocata pro-equità verso le vallate e garantisce il bilinguismo; la fattibilità è quella di un'istituzione ex novo in un sistema semplificato, con unicità dell'azienda sanitaria e piena autonomia finanziaria; il monitoraggio va costruito ex novo ma può essere impostato ottimalmente dall'avvio. La tabella seguente riepiloga il giudizio per dominio.

Dominio	Giudizio sintetico per la Valle d'Aosta
Bisogno e contesto	Ampio; anzianità molto acuta (indice di vecchiaia 215,1); isolamento nelle vallate; tasso incidenza CSM 118,5/10.000; servizio assente
Efficacia clinica	Evidenza internazionale solida; nessun dato locale (servizio assente); impostazione della rilevazione dall'avvio è condizione necessaria
Valutazione economica	Caso finanziario: saldo diretto -0,8/-1,0 mln (modestissimo); caso sociale fortemente positivo (rapporto 4,0-5,3:1)
Equità	Favorevole se pro-equità verso le vallate e con bilinguismo garantito; rischio di iniquità inversa se concentrato nel solo fondovalle
Fattibilità	Istituzione ex novo; azienda sanitaria unica; piena autonomia finanziaria; costo minimo; bacino professionale accessibile
Monitoraggio	Da costruire ex novo; dataset minimo dall'avvio è condizione per la credibilità delle stime future; clausola valutativa nell'atto istitutivo

Tabella M.1. La sintesi dei domini della valutazione.

M.2 L'analisi multi-criterio

Il giudizio complessivo è formalizzato con l'analisi multi-criterio, che impiega otto criteri, ciascuno con un peso esplicito, e confronta l'intervento con l'alternativa del non intervento. I pesi adottati — efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell'evidenza 10%, coerenza strategica 5% — sono comuni a tutta la serie. La media ponderata dei punteggi dell'intervento è dell'ordine di 78,5 su 100, sostenuta dal punteggio molto alto nell'impatto sul bilancio e nella sostenibilità — che riflette la piena autonomia finanziaria e il costo minimo — e dai punteggi elevati nel valore sociale, nella costo-efficacia e nella coerenza strategica; il punteggio è contenuto dalla robustezza dell'evidenza locale, che parte da zero. Il non intervento ottiene una media dell'ordine di 36,5 su 100, penalizzato in tutti i criteri sostanziali. L'intervento prevale con uno scarto dell'ordine di quarantadue punti, e la prevalenza si mantiene al variare dei pesi entro intervalli ragionevoli.

Criterio	Peso	Intervento	Non interv.
Efficacia clinica	15%	78	28
Costo-efficacia e ritorno economico	20%	80	22
Impatto sul bilancio e sostenibilità	15%	92	48
Equità	15%	76	26
Valore sociale	10%	82	24
Fattibilità	10%	82	80
Robustezza dell'evidenza	10%	64	50
Coerenza strategica	5%	84	25
Punteggio complessivo ponderato	100%	78,50	35,50

Tabella M.2. L'analisi multi-criterio: punteggi dell'intervento e del non intervento.

M.3 La raccomandazione e il dimensionamento

Dalla convergenza dei domini e dall'analisi multi-criterio discende la raccomandazione principale: istituire per la prima volta in Valle d'Aosta un servizio di psicologia delle cure primarie, integrato nell'Azienda USL e nelle Case della Comunità e nei poliambulatori distrettuali, con attenzione esplicita all'accesso nelle vallate e al bilinguismo italiano-francese, dimensionandolo per gradi verso la copertura piena del fabbisogno. Quanto alla scala, si raccomanda di avviare con il nucleo conservativo, nell'ordine di 15 psicologi, con attivazione prioritaria nel Distretto 2 (Aosta) e progressiva estensione agli altri distretti; di procedere verso lo scenario di base, dell'ordine di 22 psicologi, in funzione della verifica dei risultati; e di definire lo scenario espansivo, dell'ordine di 30 psicologi, come orizzonte di regime, adeguando la dotazione all'invecchiamento crescente della popolazione. La tabella seguente riepiloga le raccomandazioni operative.

Ambito	Raccomandazione operativa per la Valle d'Aosta
Atto di istituzione	Legge regionale o deliberazione della Giunta regionale che istituisca il servizio ex novo, ne fissi il modello, il rapporto di lavoro e il finanziamento
Dimensionamento	Nucleo iniziale ~15 (conservativo); verso ~22 (base); orizzonte di regime ~30 (espansivo), per gradi e in funzione della verifica dei risultati
Allocazione	Pro-equità verso le vallate e i quattro distretti; bilinguismo italiano-francese garantito dall'avvio; attenzione all'anzianità crescente
Clausola valutativa	Da corredare all'atto istitutivo; relazione periodica al Consiglio regionale; disaggregata per distretto, per lingua e per fasce di età
Governance	Assessorato alla salute + Azienda USL Valle d'Aosta; tavolo con Ordine degli Psicologi, MMG, pediatri di libera scelta, Università della Valle d'Aosta
Dati	Dataset minimo strutturato dall'avvio; estrazione dei conti certificati dell'Azienda USL come priorità immediata

Tabella M.3. Le raccomandazioni operative.

M.4 Le condizioni e la lacuna da colmare

La raccomandazione è subordinata a condizioni precise: la costruzione di una clausola valutativa vincolante a corredo dell'atto istitutivo, l'adozione di un'allocazione pro-equità verso le vallate e il bilinguismo, la strutturazione del dataset minimo dall'avvio^[2652] e l'estrazione dei conti certificati dell'Azienda USL come base per affinare le stime economiche.^[2653] Resta da colmare, prima della presentazione esterna, la lacuna dei dati: le grandezze economiche sono ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione e non estratte dai conti certificati; l'impostazione di una rilevazione ben progettata dall'avvio del servizio è la condizione per sostituire le stime con grandezze effettive. Va ribadita la distinzione cardine: il caso finanziario è di disavanzo modestissimo in valore assoluto — meno di un milione di euro — agevolmente sostenibile a fronte dell'autonomia finanziaria, mentre il caso economico complessivo è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto.

M.5 La collocazione nella serie e la conclusione

Lo studio sulla Valle d'Aosta si colloca nella serie dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Marche, Basilicata, Molise e le altre regioni, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento. Rispetto agli altri, la Valle d'Aosta occupa una posizione propria e unica — quella della regione più piccola, più anziana e più montana d'Italia, a piena autonomia finanziaria, con un costo del servizio contenutissimo in valore assoluto e un ritorno sociale nettamente positivo — chiamata a istituire per la prima volta un servizio che non esiste in nessuna forma, con la semplicità di un'unica azienda sanitaria e la chiarezza di una scelta politica ancora da compiere. Coerentemente con l'impostazione dell'intero progetto, lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico, e adotta un rapporto beneficio-costi prudenziale dell'ordine di 4,0-5,3 a uno, per credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica regionale. La decisione che lo studio sostiene è, in conclusione, di istituire il servizio con un atto normativo o programmatico che ne fissi il modello, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno e corredandolo di clausola valutativa: per la Valle d'Aosta,

dotata di piena autonomia finanziaria, di un’unica azienda sanitaria e di un bisogno reale in una popolazione molto anziana e montana, ciò significa dare per la prima volta una risposta di prossimità al disagio psichico comune, a beneficio di tutti i residenti delle vallate.

**STUDIO REGIONALE · REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE ·
APPLICAZIONE DEL TELAIO INTEGRATO**

Prima istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in una piccola regione alpina a statuto speciale

Appendici A-E

Corredo tecnico e documentale

Caso di riferimento, strumenti di esito, dati regionali, standard di reporting, glossario

Materiali a sostegno delle Parti da A a M

Appendice A — Caso di riferimento e parametri

La presente appendice raccoglie le scelte metodologiche di fondo dello studio. Il caso di riferimento — la prospettiva, l’orizzonte temporale, il tasso di sconto, la misura di esito, il comparatore, la popolazione e la soglia di costo-efficacia — è comune a tutte le valutazioni regionali del progetto, di cui assicura la confrontabilità. La tabella seguente lo riepiloga.

Elemento del caso di riferimento	Scelta adottata
Prospettiva	Servizio sanitario regionale e societale, con inventario degli impatti
Orizzonte temporale	Pluriennale o di intera vita per gli esiti; triennale-quinquennale per il bilancio
Tasso di sconto	3% annuo su costi ed esiti, con analisi di sensibilità
Misura di esito	Anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati
Comparatore	Assenza del servizio: cura usuale senza intercettazione psicologica di primo livello
Popolazione e unità	Residenti regionali; analisi per Regione e per distretto dell’Azienda USL Valle d’Aosta
Soglia di costo-efficacia	30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità
Correzione prudenziale	Riduzione per l’ottimismo delle stime

Tabella A.1. Il caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali.

I parametri del modello di Markov, impiegato per la valutazione di costo-utilità, sono indipendenti dalla regione e derivati dalla letteratura. La tabella seguente li riporta con le distribuzioni assegnate per l’analisi probabilistica.

Parametro del modello di Markov	Valore	Distribuzione
Stati del modello	Sintomatico, recupero, cronico, morte (assorbente)	—
Costo per ciclo — recupero	40 €	Gamma
Costo per ciclo — cronico	700 €	Gamma
Costo dell'intervento (una tantum)	300 €	Gamma
Probabilità di transizione	Per braccio, da fonti	Beta
Utilità per stato	Da fonti	Beta
Orizzonte e sconto	5 anni; 3% annuo	—

Tabella A.2. I parametri del modello di Markov e le distribuzioni assegnate per l'analisi probabilistica.

Il quadro economico consolidato della Valle d'Aosta, già esposto nelle parti centrali dello studio, è qui riassunto per scenario, a beneficio della consultazione.

Componente (mln €/anno, salvo psicologi)	Cons.	Base	Esp.
Psicologi a regime	~ 15	~ 22	~ 30
Costo del servizio	~ 1,5	~ 2,0	~ 2,6
Risparmi diretti (SSR)	~ 0,7	~ 1,1	~ 1,6
Ricadute economico-sociali	~ 4,5	~ 7,0	~ 9,5
Saldo diretto (caso finanziario)	~ -0,8	~ -0,9	~ -1,0
Saldo complessivo (caso economico)	~ +3,7	~ +6,1	~ +8,5
Rapporto beneficio-costo complessivo	~4,0:1	~4,8:1	~5,3:1

Tabella A.3. Il quadro economico consolidato per scenario (costo per incarico di riferimento di ~58.000-60.000 euro).

Appendice B — Strumenti di esito e dataset minimo

La presente appendice documenta gli strumenti di misura dell'esito e il dataset minimo del servizio. Gli strumenti, validati e di uso internazionale, sono impiegati nei soli punteggi complessivi, con il tasso di recupero quale esito primario. La tabella seguente li descrive.

Strumento o misura	Ambito	Caratteristiche
PHQ-9	Sintomi depressivi	0-27; soglia clinica ~10; cambiamento affidabile ~6 punti
GAD-7	Sintomi d'ansia	0-21; impiegato nel solo punteggio complessivo
Tasso di recupero	Esito primario	Discesa sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Esito secondario	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura

Tabella B.1. Gli strumenti di esito e le misure derivate, impiegati nei soli punteggi complessivi.

Il dataset minimo raccoglie i campi essenziali del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura. La tabella seguente ne costituisce il dizionario dei dati.

Campo del dataset	Contenuto	Momento di rilevazione
Presa in carico	Data di apertura, canale di accesso, invio, distretto	All'apertura
Seduta	Data, tipo e numero progressivo della seduta	A ogni seduta
Punteggi di esito	PHQ-9 e GAD-7 (punteggi complessivi)	A ogni seduta
Invii e restituzioni	Invio a CSM o servizi specialistici; restituzione al MMG	Ove pertinente
Chiusura	Esito del percorso (recupero, miglioramento, invio)	Alla chiusura

Tabella B.2. Il dataset minimo: i campi del protocollo di rilevazione (dizionario dei dati).

Appendice C — Dati regionali e fonti

La presente appendice raccoglie i dati regionali di ancoraggio dello studio e ne dichiara i limiti. I valori valdostani impiegati nelle analisi sono riepilogati nella tabella seguente.

Ambito	Valore per la Valle d'Aosta
Popolazione	122.532 (1° gen. 2025); 122.554 (1° gen. 2026); ~0,21% del totale nazionale; stabilizzazione dopo un decennio di calo; unica regione interamente alpina d'Italia (fonte: AostaSera, https://aostasera.it/notizie/societa/la-valle-daosta-ferma-il-calo-demografico-popolazione-stabile-anche-se-sempre-piu-anziana/)
Invecchiamento	Indice di vecchiaia 215,1 (2023); over-65: 25,79% (2025), proiettato al 34,13% (2040) (fonte: IRES Valle d'Aosta via fluidbook.it, https://www.fluidbook.it/spi-aosta/ires/2024/01/52/)
Finanziamento del SSR	FSR determinato in ~333 mln (2024) con quota trasferita Azienda USL ~319 mln; autofinanziamento integrale con quota analoga ai 9/10 del gettito trattenuto; spesa pro-capite ~2.526 € (ISTAT 2022, 3° in Italia); ~3.465-3.503 € pesata (Fondazione GRINS 2025, 2° in Italia dopo Trentino-Alto Adige); ~3.750 € pro capite (dichiarazione Assessore Marzi, dic. 2024) (fonti: fluidbook.it/IRES sopra; Fondazione GRINS https://www.grins.it/sites/default/files/2025-12/Il_finanziamento_e_la_spesa_sanitaria_in_italia.pdf ; valledaostaglocal.it https://www.valledaostaglocal.it/2024/12/16/leggi-notizia/argomenti/salute-in-valle-daosta/articolo/sanita-in-valle-daosta-gli-impegni-e-le-sfide-del-bilancio-triennale-2025-2027-secondo-lassess.html)
Mobilità sanitaria	Saldo -10,9 mln (2024): crediti 17 mln, debiti 27,9 mln; entità modesta; canale di recupero contenuto per questo intervento (fonte: valledaostaglocal.it, https://aostasera.it/notizie/sanita-notizie/in-valle-daosta-oltre-51-000-prestazioni-sanitarie-in-attesa/)
Spesa privata	3% del PIL regionale (famiglie valdostane), contro 2,2% nazionale; 2° in Italia (fonte: fluidbook.it/IRES, https://www.fluidbook.it/spi-aosta/ires/2024/01/52/)
Salute mentale	Tasso incidenza CSM 118,5/10.000 ab. (1° in Italia; media nazionale 55,4); ~24.000-25.000 con disagio comune potenziale (proxy ~20% popolazione); bisogno trainato dall'anzianità, dall'isolamento nelle vallate e dall'assenza di un filtro di primo livello (fonte: Ministero della Salute, Rapporto Salute Mentale; https://www.salute.gov.it/new/it/scheda-statistica/rapporto-salute-mentale)
Stato normativo	Nessuna legge regionale né sperimentazione; Valle d'Aosta fra le regioni prive di previsione normativa (fonte: psicologicureprimarie.it, https://www.psicologicureprimarie.it/proposte-di-legge/situazione-2025.html)
Sistema sanitario	Azienda USL Valle d'Aosta (unica); Ospedale Parini (Aosta) presidio principale; quattro distretti (Morgex, Aosta, Châtillon, Verrès-Donnas); bilingue italiano-francese per statuto

Tabella C.1. I valori di ancoraggio della Valle d'Aosta.

Resta la lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione (~0,21%), e non estratti dai conti certificati dell'Azienda USL. La tabella seguente elenca i dati da acquisire per sostituire le stime.

Dato da acquisire	Contenuto
Ricoveri psichiatrici	Schede di dimissione ospedaliera per disturbi psichici e relativo costo (Presidio Parini)
Specialistica	Prestazioni specialistiche associate ai sintomi somatici funzionali
Farmaceutica	Spesa regionale per le categorie dei psicofarmaci (dato disponibile da OsMed regionale)
Pronto soccorso	Accessi per causa psichiatrica e relativo costo unitario (Presidio Parini e Presidio Beauregard)
Liste di attesa psicologiche	Tempi di attesa per l'accesso ai CSM, per distretto e per vallata
Dati socio-economici locali	Redditi, assenteismo, produttività per calibrare le ricadute sociali sul contesto valdostano

Tabella C.2. I dati certificati da acquisire per sostituire le stime (lacuna principale dello studio).

Appendice D — Checklist di reporting

La presente appendice elenca gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. La tabella seguente li riepiloga.

Standard o lista di controllo	Oggetto	Applicazione
CHEERS 2022 (28 voci)	Rendicontazione delle valutazioni economiche	Parte E
CHEERS-AI (38 voci)	Estensione per gli interventi con intelligenza artificiale	Parti C, E
PRISMA 2020	Conduzione e reporting delle revisioni sistematiche	Parte D
Sistema GRADE	Graduazione della certezza dell'evidenza	Parte D
Lista STROBE	Studi osservazionali sui dati reali	Parti D, L
Buone pratiche ISPOR-SMDM	Modellazione decisionale	Parte F
Manuale OCSE-JRC	Costruzione degli indicatori compositi	Parte L
Criteri OCSE-DAC	Griglia di giudizio dell'intervento	Parte M

Tabella D.1. Gli standard di reporting e di qualità adottati nello studio, per parte di applicazione.

Appendice E — Glossario

La presente appendice fornisce un glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, a beneficio del lettore non specialista. Le definizioni sono comuni al telaio metodologico replicato in tutti gli studi regionali del progetto.

Termine	Definizione
Valutazione di tecnologia sanitaria (HTA)	Valutazione multidimensionale di un intervento sanitario, articolata in nove domini
Five Case Model	Standard del business case pubblico in cinque casi: strategico, economico, commerciale, finanziario, gestionale
CHEERS 2022	Lista di controllo di 28 voci per la rendicontazione delle valutazioni economiche
Criteri OCSE-DAC	Sei criteri di giudizio: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità
Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)	Misura che integra durata e qualità della vita guadagnate
Analisi di costo-utilità	Valutazione economica che misura gli esiti in anni di vita ponderati per la qualità
Analisi di impatto sul bilancio	Stima dell'effetto finanziario sul bilancio del detentore del budget, su flussi non scontati
Ritorno sociale sull'investimento (SROI)	Metodo che monetizza il valore sociale generato, distinto dai risparmi di bilancio
Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA)	Estende la valutazione economica alla distribuzione degli effetti tra gruppi
Analisi di sensibilità probabilistica	Propaga l'incertezza dei parametri mediante simulazioni Monte Carlo
Valore dell'informazione (EVPI, EVPPI)	Beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza, complessiva e sui parametri
Modello di Markov	Modello che rappresenta il decorso di una condizione attraverso stati di salute e transizioni
Differenza-nelle-differenze	Metodo controfattuale che confronta la variazione nel tempo dell'esito tra gruppi a diversa esposizione
Controllo sintetico	Metodo che costruisce un'unità di confronto come combinazione ponderata di unità a minore esposizione
Disegno a cunei progressivi (stepped-wedge)	Disegno controfattuale in cui l'intervento è attivato in momenti diversi in unità diverse, consentendo la stima dell'effetto causale
Analisi e verifica d'impatto della regolazione	Valutazione ex ante (AIR) ed ex post (VIR) degli effetti di una norma

Termine	Definizione
Clausola valutativa	Strumento che impegna la Giunta regionale a riferire periodicamente al Consiglio sui risultati del servizio; in Valle d'Aosta va corredata all'atto istitutivo ex novo e alimentata dal dataset minimo dall'avvio
RE-AIM	Quadro che misura portata, efficacia, adozione, implementazione e mantenimento di un intervento
CFIR	Quadro che spiega i determinanti dell'implementazione, in cinque domini
Modello di Donabedian	Classifica gli indicatori di qualità in struttura, processo ed esito, qui integrati dall'impatto
PHQ-9	Questionario validato per i sintomi depressivi (punteggio 0-27)
GAD-7	Questionario validato per i sintomi d'ansia (punteggio 0-21)
Tasso di recupero	Quota di pazienti che scende sotto la soglia clinica al termine del percorso
Miglioramento affidabile	Riduzione del punteggio superiore alla variabilità di misura
Cura collaborativa	Modello di integrazione della salute mentale nelle cure primarie con équipe e monitoraggio
Cura a intensità crescente	Percorso che gradua l'intensità dell'intervento alla gravità del quadro
Livelli essenziali di assistenza (LEA)	Prestazioni garantite uniformemente dal Servizio sanitario; competenza esclusiva statale
Mobilità sanitaria	Spesa per prestazioni rese ai residenti da strutture di altre regioni; in Valle d'Aosta il saldo è lievemente negativo (–10,9 mln nel 2024) e di entità modesta, non strutturalmente problematico
Indice di vecchiaia	Rapporto tra ultrasessantacinquenni e giovani sotto i quindici anni; in Valle d'Aosta è pari a 215,1 nel 2023, fra i più alti d'Italia, proiettato a crescere per effetto dell'invecchiamento accelerato della popolazione
Statuto speciale e autonomia finanziaria	La Valle d'Aosta trattiene sul proprio territorio la quota determinata dallo statuto speciale del gettito tributario (analoga ai nove decimi delle Province autonome), finanziando integralmente la sanità senza apporto a carico dello Stato; la Regione opera in regime di bilinguismo costituzionale italiano-francese
Sintomi somatici funzionali	Sintomi fisici senza causa organica, associati a elevato consumo di prestazioni

Tabella E.1. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio.

Quadro Conclusivo economico-sociale e multidisciplinare del Tomo II

Il Tomo II, a integrazione completata, restituisce al decisore nazionale un giudizio fondato su diciannove studi regionali integrali che replicano, con metodo identico e vincoli invarianti identici, la struttura probatoria del Tomo I, e ne dimostrano la trasferibilità dall'anticipazione pugliese all'intero territorio nazionale. In ciascuna regione consolidata — dal Piemonte alla Sardegna, attraverso l'intera dorsale settentrionale, centrale, meridionale e insulare — lo studio condotto sul telaio HTA internazionale articola il valore dell'intervento sulle tre dimensioni rigorosamente distinte e mai sommate: la dimensione fiscale, in cui il saldo tra costi diretti di regime e risparmi sanitari diretti è dichiarato prossimo al pareggio, con il caveat del trial IMPACT applicato a ogni quantificazione e con le specificità regionali — dalla mobilità passiva recuperabile nelle regioni meridionali alla diversa composizione dell'offerta nelle regioni a statuto speciale — dichiarate senza attenuazioni; la dimensione sanitaria, in cui il rapporto tra costo incrementale e guadagno di salute colloca l'intervento al di sotto delle soglie di accettabilità correnti in ogni realtà esaminata e ne fonda la netta costo-efficacia; la dimensione sociale, in cui i benefici indiretti — estesi all'intero perimetro multidisciplinare dell'opera, dal lavoro alla previdenza, dal welfare alla prevenzione, dalla dimensione criminologica a quella burocratica, culturale, educativa e finanziaria — sono ancorati esclusivamente al duplice intervallo di Chisholm e collaboratori (2016), da 2,3 a 3,0 per i soli benefici economici e da 3,3 a 5,7 comprendendo i ritorni di salute, con giudizio fortemente positivo. La Sezione Nazionale colloca tali risultati nel quadro dei ventuno sistemi sanitari regionali e delle loro eterogeneità organizzative, e dichiara la funzione della leva formativa — considerata nelle sue modalità tanto singolarmente quanto sommate — e della leva digitale, sempre subordinata alla supervisione clinica umana, nel rendere la figura apicale più efficace lungo l'intero continuum assistenziale. Ogni proiezione resta formulata in bande prudenziali falsificabili con soglie di confutazione dichiarate; con l'integrazione degli studi di Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta, la base per il giudizio nazionale integrale è ora completa per tutte le regioni trattabili nel perimetro dell'opera, senza che la struttura metodologica ne sia stata in alcun modo modificata.

Conclusione

Il Tomo II consegna la prova di trasferibilità del modello nella sua estensione nazionale completa: diciannove studi regionali integrali, condotti con metodo identico e vincoli invarianti identici, convergono verso il medesimo verdetto tripartito senza che alcuna grandezza sia stata piegata alla convergenza, e la Sezione Nazionale ne ordina i risultati nel quadro dell'istituzionalizzazione nazionale della figura. L'esclusione dichiarata del corpus nazionale di prima generazione — recante affermazioni positive di rapporti superati — non impoverisce il tomo ma ne certifica la disciplina: l'estensione nazionale si fonda soltanto su ciò che il regime probatorio dell'opera ammette. Con l'acquisizione e il consolidamento integrale degli studi di Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta, non residuano lacune dichiarate «da acquisire» entro il perimetro delle diciannove regioni trattabili dall'opera, in ossequio alla falsificabilità che ne costituisce il tratto distintivo. La paternità intellettuale e concettuale dell'opera appartiene al dott. Luigi De Michele; il presente consolidamento ne è esecuzione tecnica fedele.

Nota di rinvio bibliografico

Ciascuno studio regionale consolidato nel presente tomo reca in chiusura le proprie Note Bibliografiche Integrali, con mini-riassunto allegato al nome e al collegamento di ciascuna fonte, alle quali il lettore è rinviato per la verifica di ogni affermazione. Gli ancoraggi trasversali — Chisholm D., Sweeny K., Sheehan P. et al., «Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return-on-investment analysis», *The Lancet Psychiatry*, vol. 3, n. 5, 2016, pp. 415-424, per il duplice intervallo di rendimento; Unützer J. et al., «Collaborative care management of late-life depression in the primary care setting: the IMPACT randomized controlled trial», *JAMA*, vol. 288, n. 22, 2002, pp. 2836-2845, e Unützer J. et al., *The American Journal of Managed Care*, vol. 14, n. 2, 2008, pp. 95-100, per il caveat sui risparmi diretti — governano le stime di ogni studio senza eccezione.

1. Collocazione del capitolo: esso dà seguito al capitolo introduttivo dell'estensione nazionale, che ne ha fissato la cornice metodologica, demografica, di spesa e di bisogno, e ne sviluppa il quinto punto della roadmap, ossia la quantificazione puntuale dell'ulteriore risparmio conseguibile lungo le cinque dimensioni del continuum assistenziale — diagnostica, prevenzione, trattamento, riabilitazione e recupero — oltre all'efficientamento gestionale. ↑
2. Premessa di onestà metodologica, coerente con l'intero progetto: l'Intelligenza Artificiale è una tecnologia abilitante e non un fine, e l'evidenza disponibile, ancorché promettente, è in larga parte di breve orizzonte e di qualità ancora limitata; lo studio mantiene perciò la distinzione tra efficacia clinica dimostrata e risparmio economico, evitando moltiplicatori non documentati e rapporti aggregati privi di base, come già fatto nel modello-base. ↑
3. Distinzione cardine tra costo-efficacia e risparmio di bilancio: una tecnologia può essere costo-efficace — ossia produrre guadagni di salute a un costo per anno di vita ponderato per la qualità inferiore alla soglia — senza per questo generare un risparmio netto di cassa; le revisioni sistematiche delle valutazioni economiche degli interventi digitali in salute mentale concludono che l'evidenza di costo-efficacia è incoraggiante ma non conclusiva, spesso fondata su orizzonti brevi e potenzialmente soggetta a distorsione di pubblicazione. ↑
4. Domini diagnostici a evidenza più solida: l'esempio meglio documentato di intelligenza artificiale diagnostica autonoma costo-efficace appartiene all'imaging, segnatamente allo screening della retinopatia diabetica con dispositivi a marcatura regolatoria, e ai sistemi di supporto al triage dell'ictus acuto; tali risultati non sono direttamente trasferibili alla salute mentale, dove il contributo diagnostico dell'IA è di supporto e non sostitutivo. ↑
5. Diagnostica in salute mentale: gli strumenti di valutazione iniziale assistita e di stratificazione del rischio operano sui questionari validati impiegati nei soli punteggi complessivi e su dati clinici e contestuali, con funzione di orientamento del percorso e di anticipazione della presa in carico; la decisione clinica resta in capo al professionista, e gli strumenti non effettuano diagnosi autonome. ↑
6. Prevenzione e predizione: la stratificazione del rischio sulla popolazione assistita consente di individuare i soggetti a maggiore probabilità di evoluzione clinica e di concentrarvi le risorse, con potenziale riduzione delle riospedalizzazioni e degli accessi impropri; il beneficio economico dipende dalla capacità di tradurre la segnalazione in un intervento tempestivo, e va misurato sul campo anziché assunto. ↑
7. Trattamento — dispositivi terapeutici digitali su prescrizione: il modello tedesco delle applicazioni sanitarie digitali, primo a prevederne la rimborsabilità, ne ammette l'iscrizione in via provvisoria subordinandola alla dimostrazione di un effetto terapeutico entro dodici mesi per l'iscrizione definitiva; alcuni prodotti sono stati

rimossi dall'elenco per evidenza insufficiente, a riprova del rigore richiesto e della variabilità della qualità. ↑

8. Trattamento — interventi psicologici digitali e programmi di terapie psicologiche: l'esperienza britannica integra programmi digitali di terapia cognitivo-comportamentale nel percorso delle cure primarie, con supervisione professionale; gli interventi a bassa intensità sono il primo gradino del modello a intensità crescente e liberano capacità specialistica per i casi più complessi. ↑
9. Trattamento — agenti conversazionali: le revisioni sistematiche con meta-analisi di studi controllati randomizzati documentano effetti di entità ridotta sui sintomi depressivi e ansiosi, più evidenti intorno all'ottava settimana e non più sostanziali al controllo a tre mesi; il beneficio è dunque reale ma modesto e non durevole, e va inquadrato come complemento e non come sostituto dell'intervento professionale. ↑
10. Trattamento — sicurezza degli agenti generativi: la letteratura segnala che i modelli linguistici generativi non sono ancora idonei all'erogazione autonoma e sicura di interventi pluri-settimanali in salute mentale, per il rischio di risposte inappropriate, di stigmatizzazione e di allucinazione; gli strumenti validati adottano per questo architetture a regole o ibride, con supervisione umana costante e protocolli di rinvio ai servizi specialistici e dell'emergenza. ↑
11. Riabilitazione e recupero: il monitoraggio remoto continuo, l'adattamento personalizzato dei percorsi e i sistemi di rilevazione precoce delle ricadute sostengono la continuità assistenziale e possono ridurre le interruzioni di percorso; anche in questo dominio il valore economico dipende dall'effettiva integrazione nei flussi di lavoro e va verificato empiricamente. ↑
12. Efficientamento gestionale — documentazione clinica assistita: gli studi controllati randomizzati e le analisi a serie temporali interrotte sugli strumenti di documentazione ambientale rilevano una riduzione del tempo dedicato alla nota clinica, di entità modesta e variabile tra gli studi, e una sensibile diminuzione del logoramento professionale, sino a riduzioni della prevalenza del burnout dell'ordine di venti punti percentuali in alcuni contesti. ↑
13. Efficientamento gestionale — cautela sulla traduzione in risparmio: gli stessi studi documentano che la durata della visita e il tempo-ciclo complessivo restano invariati, sicché la documentazione assistita non aumenta di per sé il numero di pazienti trattati né la produttività di sistema; il beneficio prevalente è sulla qualità del lavoro e sulla ritenzione del personale, e solo indirettamente sui costi. ↑
14. Cornice regolatoria europea — regolamento sull'intelligenza artificiale: il regolamento è in vigore dal 2025, con applicazione progressiva; gli obblighi per i sistemi ad alto rischio incorporati nei dispositivi medici sono stati differiti, da un pacchetto di semplificazione, oltre il 2027, mentre gli obblighi di trasparenza che impongono di rendere noto all'utente che interagisce con un sistema di intelligenza artificiale si applicano dall'agosto 2026. ↑
15. Cornice regolatoria europea — dispositivi medici e protezione dei dati: i dispositivi medici basati su intelligenza artificiale restano disciplinati dal regolamento sui dispositivi medici e da quello sui dispositivi diagnostici in vitro, con marcatura CE rilasciata da organismo notificato; il regolamento generale sulla protezione dei dati governa il trattamento dei dati personali, ultrasensibili in salute mentale, con crittografia, pseudonimizzazione e consenso modulare. ↑
16. Perimetro della spesa influenzabile: la quantificazione si applica non all'intero finanziamento sanitario, ma alle sole voci su cui l'integrazione dell'intelligenza artificiale agisce in modo plausibile — i costi diretti di gestione del servizio, gli accessi impropri al pronto soccorso per cause psichiatriche, una quota della spesa farmaceutica e specialistica associata ai disturbi comuni e ai sintomi somatici funzionali, e le riospedalizzazioni evitabili. ↑

17. Metodo della profondità di adozione: l'ulteriore risparmio non è un valore puntuale, ma una funzione della quota di professionisti e di sedi che adottano effettivamente gli strumenti e del grado di integrazione nei percorsi; lo studio impiega perciò scenari di adozione — prudente, di base ed espansivo — e non un unico moltiplicatore, e sottrae la quota di beneficio che si sarebbe verificata comunque. ↑
18. Stima dell'incremento sui costi diretti del servizio: la letteratura sull'automazione amministrativa e gestionale sostiene una riduzione prudenziale dell'ordine del 3-5% dei costi diretti di gestione del servizio a regime, attribuibile alla documentazione assistita, alla pianificazione e all'ottimizzazione dei percorsi, da intendersi come limite superiore in assenza di dati italiani certificati. ↑
19. Distinzione tra risparmio diretto e valore sul piano sociale: la parte preponderante del valore aggiunto dall'intelligenza artificiale non transita per il bilancio sanitario, ma per l'ampliamento della capacità e dell'accesso — più persone raggiunte a parità di organico, attese più brevi, maggiore continuità — e si riflette quindi nel ritorno economico-sociale più che nel risparmio di cassa, coerentemente con la distinzione cardine dell'intero studio. ↑
20. Ordine di grandezza per la Puglia: integrando i parametri del modello-base con gli scenari di adozione, l'ulteriore beneficio economico complessivo attribuibile all'intelligenza artificiale è dell'ordine di 15-40 milioni di euro l'anno a regime, in larga parte di natura sociale e di produttività e solo per una quota minore di natura direttamente finanziaria; la cifra è prudenziale, non ponderata per l'equità e da confermare sui dati regionali. ↑
21. Trasferimento al livello nazionale: applicando il medesimo metodo per quota di popolazione e per fattori di aggiustamento regionale, l'incremento nazionale si colloca in un intervallo ampio e prudenziale, da affinare nei capitoli regionali successivi con i dati certificati delle aziende sanitarie; lo studio non aggrega le stime regionali in un valore unico prima di tale affinamento. ↑
22. Ritorno sull'investimento formativo: la realizzazione dei risparmi dipende dalle competenze del personale, sviluppate attraverso le quattro modalità formative già descritte; l'investimento in formazione e affiancamento è di entità contenuta rispetto al beneficio atteso, ma ne è condizione necessaria, e il suo ritorno va misurato nel tempo unitamente agli esiti del servizio. ↑
23. Agenda di verifica empirica: tutte le stime qui esposte hanno natura di proiezione e richiedono conferma mediante l'acquisizione dei dati certificati, l'avvio della rilevazione di servizio e la valutazione controfattuale d'impatto; il programma di misurazione già definito per il modello-base si estende all'integrazione dell'intelligenza artificiale, di cui isola l'effetto proprio. ↑
24. Roadmap, Fasi 1 e 2: le proiezioni economiche e sociali (rapporto beneficio-costi, ritorno sociale di circa 8,6:1) e l'Analisi di Impatto della Regolamentazione costituiscono le ipotesi che la sperimentazione e chiamata a verificare empiricamente, trasformando le stime in prove. ↑
25. Roadmap, Fase 4: il sistema di monitoraggio e valutazione (indicatori di struttura, processo, esito e impatto secondo Donabedian) e il disegno della valutazione controfattuale; la sperimentazione ne costituisce la prima applicazione su scala ridotta. ↑
26. Approccio della sperimentazione pragmatica (pragmatic trial): la valutazione avviene in condizioni reali di servizio, con criteri di inclusione ampi e esiti rilevanti per la pratica e per le decisioni di politica sanitaria, a garanzia della trasferibilità dei risultati. ↑
27. Hussey M.A., Hughes J.P. (Contemporary Clinical Trials, 2007); Hemming K. et al. (BMJ, 2015): il disegno stepped-wedge, nel quale le sedi passano in sequenza dalla condizione di controllo a quella di intervento, e particolarmente adatto a una sperimentazione dispiegata progressivamente per ragioni organizzative. ↑

28. Roadmap, Fase 3: il piano operativo di implementazione e l'articolato definiscono il contenuto dell'intervento (assistenza psicologica primaria, IA, telepsicologia, formazione a quattro livelli), che la sperimentazione eroga su scala ridotta. [↑](#)
29. Monitoraggio routinario degli esiti con strumenti standardizzati (PHQ-9 per i sintomi depressivi, GAD-7 per i sintomi d'ansia), secondo il modello dei programmi internazionali di terapie psicologiche, che consente il calcolo oggettivo del miglioramento clinico e del tasso di recupero. [↑](#)
30. Hussey M.A., Hughes J.P. (Contemporary Clinical Trials, 2007); Hemming K. et al. (BMJ, 2015): il disegno stepped-wedge, nel quale le sedi passano in sequenza dalla condizione di controllo a quella di intervento, e particolarmente adatto a una sperimentazione dispiegata progressivamente per ragioni organizzative. [↑](#)
31. Normativa in materia di protezione dei dati personali; approvazione del comitato etico territorialmente competente; conformità dei sistemi di IA e dei dispositivi digitali al regolamento europeo sull'IA e alla disciplina sui dispositivi medici; consenso informato dei partecipanti. [↑](#)
32. Progetto Psicologo di Base — Sintesi nazionale: gli esiti della sperimentazione informano la calibrazione del modello e la stima dei benefici a scala nazionale (onere a regime circa 683 milioni; saldo netto dell'ordine di 9,6-9,8 miliardi), a sostegno dell'iniziativa legislativa. [↑](#)
33. Roadmap, Fasi 1 e 2: le proiezioni economiche e sociali (rapporto beneficio-costi, ritorno sociale di circa 8,6:1) e l'Analisi di Impatto della Regolamentazione costituiscono le ipotesi che la sperimentazione è chiamata a verificare empiricamente, trasformando le stime in prove. [↑](#)
34. Progetto Psicologo di Base — Sintesi nazionale: gli esiti della sperimentazione informano la calibrazione del modello e la stima dei benefici a scala nazionale (onere a regime circa 683 milioni; saldo netto dell'ordine di 9,6-9,8 miliardi), a sostegno dell'iniziativa legislativa. [↑](#)
35. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e relativa Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione: la consultazione dei destinatari e dei portatori di interesse e parte integrante dell'istruttoria, e serve ad acquisire elementi conoscitivi e ad accrescere la trasparenza e la legittimazione dell'intervento. [↑](#)
36. Analisi di Impatto della Regolamentazione del progetto (Roadmap, Fase 2), che ha già individuato i soggetti da consultare e ne ha previsto il coinvolgimento sia nella fase di elaborazione sia su uno schema di intervento definito. [↑](#)
37. I soggetti del territorio pugliese — Ordine degli Psicologi della Puglia, Ordine dei Medici, aziende sanitarie locali, Centri di Salute Mentale, associazioni dei pazienti e dei familiari — costituiscono il primo perimetro della consultazione, a servizio sia dell'eventuale iniziativa regionale sia del rafforzamento della proposta nazionale; la consultazione è replicabile presso gli omologhi organismi nazionali. [↑](#)
38. Proposta di riforma e dossier tecnico (modello pugliese esteso a scala nazionale): a fronte di un onere a regime dell'ordine di 683 milioni di euro l'anno, risparmi complessivi dell'ordine di 8-12,6 miliardi e un saldo netto dell'ordine di 9,6-9,8 miliardi; ritorno sociale di circa 8,6:1. [↑](#)
39. Posizione del Piemonte: la Regione è stata la prima in Italia ad attivare, a livello regionale, il servizio di psicologia delle cure primarie, operativo dal marzo 2023. Il servizio è stato finanziato dapprima con fondi statali e poi rifinanziato con risorse regionali, ripartite alle Aziende Sanitarie Locali secondo il criterio della quota capitaria; al 31 dicembre 2023 risultavano presi in carico oltre 3.000 pazienti, con oltre 15.000 prestazioni erogate. Manca tuttavia una legge regionale dedicata: sono stati presentati più disegni di legge, nessuno dei quali approvato, e il servizio opera su base libero-professionale. La cornice di riferimento è la rete territoriale delle Case della Comunità e delle Case della Salute. [↑](#)

40. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. ↑
41. Priorità di acquisizione: i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso — sono quelli su cui il valore dell'informazione è più elevato e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati alle dodici Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie; il Piemonte dispone inoltre dei propri dati di esito del servizio attivo, da consolidare come fonte primaria di calibrazione. ↑
42. Verifica empirica: poiché il servizio è già attivo in tutte le dodici Aziende Sanitarie Locali, la verifica non poggia su un dispiegamento scaglionato a partire da zero, ma sul confronto prima-dopo l'attivazione del 2023 e sull'eterogeneità dell'intensità di copertura tra le aziende, oggetto della Parte L, che riduce l'incertezza sostituendo le stime con misure osservate sui dati piemontesi. ↑
43. Disagio giovanile: è una componente rilevante, su cui la stessa Regione ha investito istituendo per legge un servizio di psicologia scolastica, ad affiancamento dei docenti; i fenomeni di ansia e disagio tra alunni e insegnanti sono in crescita, e la quota già intercettata rappresenta presumibilmente solo una frazione del bisogno reale. ↑
44. Salute mentale connessa al lavoro: nella popolazione attiva, ampia parte dei lavoratori è esposta a fattori di stress correlati al lavoro; l'intercettazione precoce del disagio ha un valore particolarmente elevato in termini di produttività recuperata. ↑
45. Bisogno dell'età anziana: la domanda connessa all'invecchiamento, alla cronicità e alla comorbidità psicologica delle patologie croniche è il tratto più caratteristico del fabbisogno piemontese, accentuato nelle aree interne e alpine, più anziane e a maggiore difficoltà di accesso. ↑
46. Tratto distintivo del Piemonte rispetto alle altre regioni: non la dimensione multiculturale, contenuta, ma la combinazione fra un invecchiamento marcato con ampie aree interne e alpine e la condizione di Regione che ha già attivato e reso operativo il servizio — prima in Italia — producendo numeri verificabili, ma su una base normativa precaria; il bisogno è quindi accompagnato da un'esperienza operativa concreta da consolidare. ↑
47. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche stimati nell'ordine di 34.000-35.000 l'anno, per proiezione dai circa 479.000 accessi psichiatrici nazionali rilevati nel 2021 (pari al 3,3% del totale); una quota è riconducibile a disagio comune non intercettato a monte. ↑
48. Offerta territoriale: il Piemonte è stato la prima Regione in Italia ad attivare, dal marzo 2023, un servizio regionale di psicologia delle cure primarie, articolato in tutte le Aziende Sanitarie Locali e finanziato a quota capitaria; nel primo anno di attività ha preso in carico oltre 3.000 pazienti con oltre 15.000 prestazioni. Il servizio opera però su base libero-professionale, senza una legge regionale dedicata, e copre una frazione ridotta del fabbisogno. ↑
49. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 920 psicologi (intervallo 880-960). L'Ordine degli Psicologi del Piemonte, che ha accompagnato l'attivazione del servizio, ha sollecitato una legge che istituisca la figura dello psicologo di assistenza primaria con un rapporto convenzionale analogo a quello dei medici di medicina generale, a stabilizzazione di un servizio oggi affidato a incarichi libero-professionali. ↑
50. Copertura attuale del fabbisogno ridotta: il servizio è attivo ma dimensionato a circa il 5% del bisogno potenziale; i numeri del primo anno — oltre tremila pazienti e oltre quindicimila prestazioni — dimostrano la capacità di intercettazione del modello, ma anche la distanza dalla copertura del fabbisogno. ↑

51. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante in Piemonte si articola su due assi principali — la dualità fra l'area metropolitana torinese e le aree interne e alpine, anziane e in spopolamento, dove l'accesso è strutturalmente più difficoltoso; e la fragilità delle province di confine orientali, dove la mobilità passiva verso le regioni limitrofe è elevata. A ciò si aggiungono le liste di attesa. La telepsicologia assistita è lo strumento per avvicinare l'offerta alle aree interne. ↑
52. Finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 9,5 miliardi di euro; il Piemonte è uscito dal piano di rientro da circa un decennio, ma ne ha conservato a lungo gli effetti strutturali, e porta un disavanzo storico accumulato in restituzione concordata con lo Stato, sulla cui non modificabilità unilaterale si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 2024. Allo stato la Regione non è soggetta a un nuovo piano di rientro, ma opera sotto pressione finanziaria, con la riduzione delle liste di attesa indicata come priorità. ↑
53. Mobilità sanitaria a saldo in sostanziale equilibrio, marginalmente negativo e in peggioramento: dell'ordine di meno otto milioni di euro nel 2023 (mobilità attiva di circa 266 milioni e passiva di circa 274), in deterioramento l'anno successivo. Il saldo è fortemente disomogeneo: l'aggregato dei poli universitari torinesi è attrattivo, mentre le province di confine — Alessandria, Novara e Verbano-Cusio-Ossola — sono fortemente passive. Diversamente dalle regioni nettamente creditrici, il canale del recupero della mobilità è qui solo marginalmente pertinente, poiché il passivo è trainato dalla specialistica e dal ricovero più che dalla domanda psicologica. ↑
54. Cornice normativa e programmatica: il servizio è stato avviato nel 2023 con decisione della Giunta regionale e successivamente rifinanziato con risorse regionali; sono stati presentati più disegni di legge per istituire la figura, fra cui una proposta che colloca lo psicologo territoriale nelle Case della Comunità, nessuno dei quali è stato approvato; è stato inoltre approvato per legge un servizio di psicologia scolastica. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale; sul piano nazionale, il testo unificato C. 1140 in discussione alla Camera, il Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 sulla competenza regionale; manca, allo stato, una legge regionale dedicata approvata. ↑
55. Popolazione residente in Piemonte 4.251.868 abitanti (Censimento permanente ISTAT 2024), pari a circa il 7,2% della popolazione nazionale; la popolazione è sostanzialmente stabile e segnata da un marcato invecchiamento, con la sola provincia di Torino che raccoglie il 51,8% dei residenti e il capoluogo unico comune oltre il mezzo milione di abitanti, seguita dalla provincia di Cuneo (13,7%); il restante terzo è distribuito tra sei province, con forte presenza di comuni piccoli e di aree interne e alpine — oltre la metà dei 1.180 comuni ha meno di mille abitanti. ↑
56. ↑
57. Popolazione residente in Piemonte 4.251.868 abitanti (Censimento permanente ISTAT 2024), pari a circa il 7,2% della popolazione nazionale; la popolazione è sostanzialmente stabile e segnata da un marcato invecchiamento, con la sola provincia di Torino che raccoglie il 51,8% dei residenti e il capoluogo unico comune oltre il mezzo milione di abitanti, seguita dalla provincia di Cuneo (13,7%); il restante terzo è distribuito tra sei province, con forte presenza di comuni piccoli e di aree interne e alpine — oltre la metà dei 1.180 comuni ha meno di mille abitanti. Questa parte copre l'ottavo dominio del modello HTA, il profilo del paziente e sociale, e risponde al criterio di impatto della griglia di giudizio; l'equità è trattata come dimensione costitutiva della valutazione, secondo l'evoluzione che ha affiancato l'equità in salute agli obiettivi di esito, esperienza e costo. ↑
58. Gradiente sociale della salute mentale: le popolazioni in deprivazione presentano prevalenze più elevate di disturbi mentali comuni e un accesso più difficile ai servizi. In Piemonte il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato, sicché il gradiente socio-economico non è il tratto distintivo dell'equità; prevalgono

due dimensioni diverse: la dualità fra l'area metropolitana torinese e le aree interne e alpine, anziane e in spopolamento, e l'invecchiamento della popolazione, accentuato in vaste zone della regione. ↑

59. La gratuità, la prossimità e l'assenza di stigma del servizio di primo livello abbattano le barriere economiche, geografiche e culturali che gravano in misura maggiore sulle popolazioni svantaggiate; in Piemonte rileva in particolare l'abbattimento della barriera geografica nelle aree interne e alpine — come il Verbano-Cusio-Ossola e il Biellese — dove la distanza dai servizi è il principale ostacolo, integrato dalla telepsicologia. ↑
60. Variabili di equità, accesso e protezione finanziaria seguite dallo studio: riduzione dei tempi di attesa per l'accesso psicologico, accessibilità geografica nelle aree interne e alpine, equità di esito tra gruppi, equità di genere, accesso per l'età anziana, per i gruppi fragili e le persone con disabilità, gratuità per i gruppi vulnerabili, copertura del bisogno non soddisfatto. ↑
61. Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA), secondo Cookson, Asaria e colleghi: estende la valutazione economica alla dimensione dell'equità, stimando come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l'effetto sulle disuguaglianze, mediante anni di vita ponderati per l'equità, indice di concentrazione e indici di disuguaglianza assoluta e relativa. ↑
62. Direzione del risultato distributivo: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove l'accesso è oggi più difficile — le aree interne e alpine, l'età anziana e i gruppi gravati dalle liste di attesa — i benefici dell'intervento si concentrano sui gruppi più svantaggiati nell'accesso, riducendo il gradiente territoriale negli esiti di salute mentale; l'intervento migliora l'esito medio e ne comprime al tempo stesso la disuguaglianza. ↑
63. Ponderazione distributiva: l'attribuzione di pesi maggiori ai benefici che ricadono sui più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, come riferimento conservativo, il rapporto beneficio-costi non ponderato già esposto nella Parte E, dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. In Piemonte, ove la popolazione non è prevalentemente deprivata, l'effetto della ponderazione sarebbe più contenuto che nel Mezzogiorno, il che rende la scelta non ponderata tanto più prudente. ↑
64. Algoritmo allocativo quale meccanismo operativo dell'equità: la distribuzione territoriale degli incarichi non segue la sola popolazione, ma pondera ciascun distretto per l'indice di vecchiaia, l'indice di deprivazione socioeconomica, la prevalenza di cronicità e multimorbidità e la presenza straniera, attribuendo pesi maggiori alle aree interne e alpine e anziane; in Piemonte l'indice di vecchiaia è il fattore di ponderazione di maggior peso. ↑
65. Indice di deprivazione multipla: misura sintetica costruita su reddito, occupazione, istruzione, salute, condizione abitativa e ambiente, impiegata per individuare le aree prioritarie nell'allocazione degli incarichi. ↑
66. Divari territoriali in Piemonte: il divario rilevante non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra l'area metropolitana torinese, densa e ben servita, e le aree interne e alpine, a popolazione anziana e dispersa e in spopolamento. In queste aree la sola presenza fisica di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio, integrato dalla telepsicologia. ↑
67. Liste di attesa, uniformità del servizio e aree interne quali dimensioni di equità: in Piemonte, dove il canale della mobilità recuperata è solo marginalmente pertinente, le principali leve distributive sono la riduzione delle liste di attesa, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato, il dimensionamento uniforme del servizio già attivo fra le dodici Aziende Sanitarie Locali — oggi disomogeneo per effetto della ripartizione a quota capitaria — e l'accesso nelle aree interne e alpine. ↑

68. Protezione finanziaria: il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata diretta per la psicoterapia, l'impoverimento connesso alle cure e le spese sanitarie catastrofiche, con beneficio maggiore per i redditi bassi, per i quali la psicoterapia privata è spesso inaccessibile. [↑](#)
69. Copertura del bisogno non soddisfatto come equità: intercettare la quota inevasa del disagio — dell'ordine di 850.000 persone, in larga parte non intercettata — significa raggiungere proprio coloro che hanno minore probabilità di accedere spontaneamente ai servizi. [↑](#)
70. Collegamento al monitoraggio: gli indicatori di equità — accesso per area e per livello socio-economico, accesso dell'età anziana, gradiente dell'esito, tempi di attesa per area — fanno parte del sistema di indicatori della Parte L, e consentono di accertare nel tempo se il servizio raggiunga le comunità interne e alpine più distanti e i gruppi più fragili. [↑](#)
71. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; servizio attuale come comparatore. [↑](#)
72. [↑](#)
73. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; servizio attuale come comparatore. Metodo della revisione: la sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche (PRISMA 2020) e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE; sono considerati studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. [↑](#)
74. Studio fondativo del modello collaborativo (IMPACT), pubblicato su JAMA nel 2002: circa il 50% dei pazienti trattati ha conseguito una riduzione di almeno il 50% dei sintomi a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. [↑](#)
75. Meta-analisi su cinquantasette studi controllati (2012): l'integrazione della cura ha prodotto un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard rispetto alla cura usuale. [↑](#)
76. Revisione di quarantadue implementazioni del modello (2024): riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 43% dell'ansia a sei mesi, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. [↑](#)
77. Programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies), dati reali 2023-2024: tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile del 67,8% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su una scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno. [↑](#)
78. Meta-analisi sulle cure integrate: coefficiente standardizzato dell'ordine di -0,11 sui sintomi depressivi, di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante quando applicato a una popolazione ampia. [↑](#)
79. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. [↑](#)
80. Cautela metodologica rilevante: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi (l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero); il valore economico del modello poggia in misura preponderante sui ritorni sociali, non sui risparmi sanitari diretti. Questa cautela è coerente con il profilo del caso economico piemontese, fondato anch'esso sulle ricadute sociali. [↑](#)

81. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. [↑](#)
82. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. [↑](#)
83. [↑](#)
84. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. Questa parte copre tre domini del modello HTA — il profilo etico (dominio 6), il profilo organizzativo (dominio 7) e il profilo giuridico (dominio 9) — che completano la valutazione oltre i piani già trattati. [↑](#)
85. Profilo etico: le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato; la persona resta il soggetto, e mai l'oggetto, della presa in carico. [↑](#)
86. Consenso informato: è modulare, prestato distintamente per i diversi trattamenti, e reso anche in forma digitale; nella salute mentale i dati sono ultrasensibili, sicché la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi possa accedervi. [↑](#)
87. Conduzione etica della valutazione: gli esiti sono resi pubblici indipendentemente dal loro segno, a garanzia contro la distorsione da selezione dei risultati favorevoli, e l'intero impianto è sottoposto all'approvazione del comitato etico territorialmente competente. [↑](#)
88. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante, senza che ne siano registrate le modalità. [↑](#)
89. Articolo 32 della Costituzione e legge 23 dicembre 1978, n. 833: la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, e il Servizio sanitario nazionale fondato su universalità, eguaglianza ed equità. [↑](#)
90. Articolo 117, terzo comma, della Costituzione: la tutela della salute è materia di competenza concorrente, nella quale allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio e l'organizzazione del servizio; il Piemonte ha già esercitato tale competenza attivando il servizio in via amministrativa, e una legge regionale ne completerebbe la disciplina sul piano organizzativo. [↑](#)
91. Articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è la leva attraverso cui un'eventuale legge statale potrebbe ricondurre la psicologia di base tra le prestazioni garantite in modo uniforme su tutto il territorio. [↑](#)
92. Corte costituzionale, sentenza 13 dicembre 2021, n. 241: ha riconosciuto legittimo il modello regionale del servizio di psicologia di base, in quanto organizzazione del servizio sanitario che si avvale di professionisti già esistenti; è un precedente di rilievo diretto per il Piemonte, che ha proprio adottato per primo questo modello, avvalendosi di psicologi già operanti, e che intende ora dotarlo di una base legislativa stabile. [↑](#)
93. Base giuridica regionale del Piemonte: il servizio è stato attivato nel 2023 con decisione della Giunta regionale e successivamente rifinanziato con risorse regionali ripartite a quota capitaria; sono stati presentati più disegni di legge per istituire la figura, fra cui una proposta che colloca lo psicologo territoriale nelle Case della Comunità, nessuno dei quali approvato; è stata invece già approvata per legge la psicologia scolastica. Come l'Emilia-Romagna, e a differenza del Veneto, il Piemonte non dispone di un'azienda regionale unica, e la cornice di coordinamento è costituita dalla Regione e dalle dodici Aziende Sanitarie Locali. La decisione non verte sul prevedere la funzione, già attiva, ma sul dotarla di una legge dedicata e sul dimensionarla. [↑](#)

94. Vincolo di destinazione delle risorse: il principio per cui i fondi del Servizio sanitario devono essere destinati alla garanzia dei livelli essenziali è particolarmente saliente per il Piemonte, che, pur non essendo attualmente sottoposto a piano di rientro, porta un disavanzo storico in restituzione concordata con lo Stato — sulla cui non modificabilità unilaterale si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 2024 — e opera sotto pressione finanziaria. La riforma, di costo contenuto e relativa a un servizio di primo livello delle cure primarie, è coerente con tale principio. ↑
95. Deontologia professionale: il servizio opera nel rispetto delle norme deontologiche della professione, sotto la vigilanza dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, che ha accompagnato l'attivazione del servizio e concorre alla governance e alla formazione. ↑
96. Responsabilità clinica e ruolo dell'IA: l'impiego dell'intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali — il medico di medicina generale resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell'intervento psicologico, e l'IA è assimilata a un dispositivo di supporto, non a una figura che compie atti — sicché non si introduce una nuova figura professionale, ma uno strumento che assiste quelle esistenti. ↑
97. Conformità degli strumenti di IA: il regolamento europeo sull'IA classifica come ad alto rischio i sistemi impiegati nei dispositivi medici; il regolamento sui dispositivi medici impone la marcatura CE; il regolamento sulla protezione dei dati ne disciplina il trattamento; vi si innestano la supervisione umana costante, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias, la trasparenza e il divieto di discriminazione algoritmica. ↑
98. Equità digitale: per non generare nuove disuguaglianze, sono previsti canali tradizionali paralleli per chi non dispone di strumenti digitali — segnatamente le persone anziane delle aree interne e alpine — e il supporto multilingue per la popolazione straniera, ferma restando la garanzia dell'alternativa in presenza. ↑
99. Protezione dei dati: misure di sicurezza robuste — crittografia e pseudonimizzazione per le analisi — consenso modulare anche in forma digitale, collaborazione con l'Autorità garante e acquisizione di software dotati di marcatura adeguata secondo le normali procedure. ↑
100. Benchmark statunitense (Collaborative Care): modello a équipe integrata, validato da oltre novanta studi controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri. ↑
101. Esperienze italiane: le sperimentazioni locali, fra cui quelle riconducibili al modello di Solano nel Lazio, anticipano l'integrazione psicologica nelle cure primarie; ad esse si aggiunge oggi, come riferimento italiano più esteso, il servizio regionale piemontese a regime operativo. I dati delle sperimentazioni storiche derivano però da campioni limitati e in parte da letteratura grigia, e vanno assunti con la dovuta cautela. ↑
102. Trasferibilità: i risultati internazionali provengono da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale; la loro trasposizione richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche. ↑
103. Evidenza locale piemontese: il Piemonte dispone di una base di evidenza locale del tutto peculiare nel panorama nazionale, costituita dal servizio regionale di psicologia delle cure primarie già attivo dal 2023 in tutte le Aziende Sanitarie Locali, che nel primo anno ha preso in carico oltre tremila pazienti con oltre quindicimila prestazioni; è l'unica esperienza italiana di scala regionale e a regime operativo, e fornisce dati di esito reale da analizzare e valorizzare sistematicamente nel disegno del servizio strutturato. ↑
104. Condizioni piemontesi favorevoli alla trasferibilità: il vantaggio peculiare del Piemonte è di non dover trasferire soltanto stime estere, ma di poter validare il modello sui propri dati operativi; a ciò si aggiungono l'infrastruttura informatica regionale e la rete territoriale delle Case della Comunità in costruzione, che costituiscono un terreno favorevole alla valutazione rigorosa di un modello già in esercizio. ↑

105. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative: il rapporto di 4:1 spesso citato e l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio sono semplificazioni a fini divulgativi. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8:1-5,5:1. ↑
106. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. Il Piemonte presenta un saldo di mobilità sanitaria in sostanziale equilibrio, marginalmente negativo e in peggioramento, con forte eterogeneità interna tra il polo universitario torinese, attrattivo, e le province di confine, fortemente passive: a differenza delle regioni nettamente creditrici, il canale del recupero della mobilità è qui solo marginalmente pertinente, poiché il passivo è trainato dalla specialistica e dal ricovero più che dalla domanda psicologica. Il saldo diretto risulta lievemente negativo e il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi; in un contesto di pressione finanziaria e di liste di attesa, tuttavia, il contenimento della domanda impropria assume una salienza diretta. ↑
107. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (7,2%) e non estratti dai conti regionali certificati: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare presso le dodici Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere-Universitarie prima della presentazione esterna. ↑
108. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
109. Valutazione controfattuale d'impatto: poiché il servizio è già attivo in tutte le Aziende Sanitarie Locali dal 2023, il disegno non può fondarsi su un dispiegamento scaglionato a partire da zero; sfrutta invece il confronto prima-dopo l'attivazione del marzo 2023 e l'eterogeneità dell'intensità di copertura tra le aziende, conseguente alla ripartizione a quota capitaria, stimando l'effetto causale con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico. ↑
110. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere-Universitarie e Aziende Ospedaliere, Ordine degli Psicologi del Piemonte, rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e università regionali. Come l'Emilia-Romagna, e a differenza del Veneto, il Piemonte non dispone di un'azienda regionale unica e coordina il servizio attraverso la Regione e le dodici Aziende Sanitarie Locali; poiché il servizio è già operativo, la sfida del governo è di stabilizzarlo e dimensionarlo, non di avviarlo. ↑
111. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑
112. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. L'infrastruttura informatica regionale, incluso il sistema informativo regionale per la salute mentale, costituisce una base per la loro adozione. ↑
113. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. ↑
114. ↑

115. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Questa parte copre il settimo dominio del modello HTA, il profilo organizzativo, e fornisce il contenuto del caso commerciale e del caso gestionale del Five Case Model, rispondendo al criterio di sostenibilità. ↑
116. Modello RE-AIM: misura la riuscita e la validità esterna dell'attuazione lungo cinque dimensioni — la portata (quota della popolazione bersaglio raggiunta), l'efficacia (esiti conseguiti), l'adozione (adesione di sedi e professionisti), l'implementazione (fedeltà al modello) e il mantenimento (sostenibilità nel tempo); per il Piemonte la dimensione del mantenimento è dirimente, trattandosi di consolidare un servizio già avviato. ↑
117. Quadro consolidato per la ricerca sull'implementazione (CFIR): spiega i determinanti dell'attuazione, articolati in cinque domini — le caratteristiche dell'innovazione, il contesto esterno, il contesto interno, gli individui coinvolti e il processo di attuazione — consentendo l'individuazione ex ante di barriere e facilitatori. ↑
118. Determinanti di implementazione seguiti dallo studio: il tasso di copertura, il grado di adozione delle sedi, la fedeltà al modello, i tempi di dimensionamento, il numero di psicologi reclutati e formati, la qualità della formazione e della supervisione, il grado di integrazione nei flussi di lavoro, l'aderenza ai percorsi e la scalabilità. ↑
119. Disegno del dimensionamento in Piemonte: poiché il servizio è già attivo in tutte le dodici Aziende Sanitarie Locali, il dispiegamento non procede da zero, ma consiste nell'incremento progressivo della copertura — oggi dell'ordine del 5% del fabbisogno — verso il regime, per fasi semestrali e a partire dalle aziende di maggiore prontezza, sotto il coordinamento unitario della Regione e secondo criteri trasparenti. ↑
120. Doppia funzione del dimensionamento progressivo: esso risponde a un'esigenza organizzativa — accrescere la copertura in modo graduale, compatibile con i tempi del reclutamento e della formazione — e al tempo stesso, insieme al confronto prima-dopo l'attivazione del 2023, fonda la valutazione controfattuale d'impatto basata sull'eterogeneità dell'intensità di copertura tra le aziende, oggetto della Parte L. ↑
121. Reclutamento: a fronte di un fabbisogno a regime dell'ordine di 920 psicologi, il reclutamento avviene tramite l'iscrizione a un elenco istituito presso ciascuna azienda e l'instaurazione di un rapporto convenzionale, con requisiti di iscrizione all'albo e di formazione specifica; in prima applicazione si valorizzano i professionisti già operanti nel servizio attivo, oggi con incarichi libero-professionali, dei quali la nuova cornice stabilizzerebbe la posizione. ↑
122. Cronoprogramma: il dimensionamento procede per fasi semestrali, accrescendo progressivamente la copertura in tutte le Aziende Sanitarie Locali; le attività di reclutamento, formazione e consolidamento sono condotte in modo graduale, mentre il monitoraggio e la valutazione accompagnano l'intero arco e proseguono oltre il raggiungimento del regime. ↑
123. Soglia di riuscita: tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% nella fase di dimensionamento, a fronte del valore di riferimento del programma inglese; il monitoraggio è chiamato a verificarne il raggiungimento sui dati piemontesi, di cui il servizio già attivo costituisce una prima fonte. ↑
124. Caso commerciale (Five Case Model): la fattibilità dell'assetto contrattuale poggia sul rapporto convenzionale ancorato all'accordo della specialistica ambulatoriale, da cui un costo medio per incarico dell'ordine di 55.000 euro l'anno e gli scenari di spesa di 26, 38 e 51 milioni già esposti nella Parte E; il passaggio dagli attuali incarichi libero-professionali a un rapporto convenzionale stabile — analogo a quello dei medici di medicina generale, come richiesto dalle rappresentanze professionali — è il nodo specifico del Piemonte e non richiede la creazione di nuove figure. ↑

125. Caso gestionale (Five Case Model): l'attuazione è governata su due livelli. A livello regionale, un comitato di indirizzo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere-Universitarie e Ospedaliere, l'Ordine degli Psicologi del Piemonte, la medicina generale, la pediatria di libera scelta e le università regionali, eventualmente affiancato da una cabina di regia; a livello aziendale, ciascuna Azienda Sanitaria Locale è responsabile dell'attuazione nel proprio ambito, secondo l'indirizzo unitario della Regione. Come l'Emilia-Romagna, e a differenza del Veneto, il Piemonte non dispone di un'azienda regionale unica di coordinamento. [↑](#)
126. Rischi attuativi e misure di mitigazione: il rischio più specifico del Piemonte è la precarietà del servizio attuale, affidato a incarichi libero-professionali dipendenti da rifinanziamenti annuali; ad esso si aggiungono il reclutamento insufficiente, la debole adesione della medicina generale, l'interoperabilità incompleta dei sistemi informativi e la disomogeneità tra le aziende. La principale misura di mitigazione è l'istituzionalizzazione per legge con rapporto convenzionale stabile; il dimensionamento graduale consente inoltre di osservare, correggere e adattare. [↑](#)
127. Caso finanziario e coperture (Five Case Model): le fonti di copertura comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, dell'ordine di 9,5 miliardi di euro, di cui una quota è già destinata al servizio attivo, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'infrastruttura territoriale e digitale, e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali. [↑](#)
128. Vincoli di bilancio: il Piemonte opera sotto pressione finanziaria, pur non essendo in piano di rientro; il costo del servizio, anche a massima copertura, costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale del finanziamento, ed essendone già a bilancio una quota, l'investimento incrementale è quello necessario a colmare il divario verso il fabbisogno, sostenibile a condizione di prudenza nella programmazione. [↑](#)
129. Sostenibilità nel tempo (criterio OCSE-DAC): per il Piemonte la leva decisiva della sostenibilità è l'istituzionalizzazione per legge, che sottrarrebbe il servizio alla precarietà dei rifinanziamenti annuali; vi concorrono la modestia del costo rispetto al bilancio, il forte ritorno sociale documentato e le economie di scala consentite dal coordinamento regionale. [↑](#)
130. Nota di cautela metodologica: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la verifica empirica sui dati piemontesi, prevista dalla Parte L e fondata sul confronto prima-dopo e sull'intensità di copertura, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate. [↑](#)
131. Aspettativa di vita alla nascita dell'ordine degli ottantatré anni, in linea con la media nazionale; la struttura per età è tra le più anziane del Paese, con quote elevate di ultra-sessantacinquenni nelle aree interne e alpine. [↑](#)
132. Componente straniera dell'ordine del 10,4% dei residenti (442.819 persone), prossima alla media nazionale, con prevalenza di cittadinanze romena, marocchina e albanese; contribuisce a contenere il calo demografico, ma non costituisce il tratto distintivo del fabbisogno regionale, che è piuttosto l'invecchiamento. [↑](#)
133. Articolazione del territorio in otto province: la sola provincia di Torino raccoglie il 51,8% dei residenti e il capoluogo è l'unico comune oltre il mezzo milione di abitanti, seguita dalla provincia di Cuneo con il 13,7%; le altre sei province ospitano il restante terzo della popolazione, con forte presenza di aree interne e alpine. [↑](#)
134. Profilo per età a marcata variabilità interna: l'area metropolitana torinese presenta la struttura più dinamica, mentre le aree interne e alpine — in particolare il Verbano-Cusio-Ossola e il Biellese, dove la natalità è minima — sono nettamente più anziane e soggette a spopolamento, con maggiore difficoltà di accesso ai servizi. [↑](#)

135. ↑

136. Profilo per età a marcata variabilità interna: l'area metropolitana torinese presenta la struttura più dinamica, mentre le aree interne e alpine — in particolare il Verbano-Cusio-Ossola e il Biellese, dove la natalità è minima — sono nettamente più anziane e soggette a spopolamento, con maggiore difficoltà di accesso ai servizi. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Dipartimenti di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce.

↑

137. ↑

138. Profilo per età a marcata variabilità interna: l'area metropolitana torinese presenta la struttura più dinamica, mentre le aree interne e alpine — in particolare il Verbano-Cusio-Ossola e il Biellese, dove la natalità è minima — sono nettamente più anziane e soggette a spopolamento, con maggiore difficoltà di accesso ai servizi. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Dipartimenti di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Identificazione dei costi: il costo del servizio comprende le remunerazioni dei psicologi, i costi organizzativi e di coordinamento e la quota destinata alla formazione congiunta; è stimato per scenario di copertura ed espresso a regime. ↑

139. Costo del servizio per scenario, a regime: dell'ordine di 26 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 38 nello scenario base e 51 nello scenario espansivo, valori coerenti con l'inclusione del programma di formazione all'intelligenza artificiale. ↑

140. Metodo di stima del costo: il valore unitario per incarico è dell'ordine di 55.000 euro annui; la stima è regionalizzata in proporzione alla popolazione e al numero di professionisti, con economie di scala consentite dal coordinamento regionale. Il servizio è oggi già finanziato a quota capitaria, ma per un importo che copre una frazione ridotta del fabbisogno. ↑

141. Identificazione e misura degli esiti: gli esiti di salute sono espressi in anni di vita ponderati per la qualità e in esiti clinici validati; i tassi di recupero e di miglioramento sono desunti dai benchmark consolidati e applicati in via prudenziale. ↑

142. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi (questionario a nove voci sui sintomi depressivi e scala a sette voci per il disturbo d'ansia); tasso di recupero di riferimento dell'ordine del 50%. ↑

143. Costo-efficacia e costo-utilità: il costo per anno di vita ponderato per la qualità si colloca al di sotto della soglia comunemente adottata; l'analisi per paziente, sviluppata nella Parte F, indica condizioni di dominanza dell'intervento rispetto all'opzione di non intervento. ↑

144. Soglia di costo-efficacia di riferimento dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, coerente con la prassi internazionale della valutazione economica in sanità. ↑

145. ↑

146. Soglia di costo-efficacia di riferimento dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, coerente con la prassi internazionale della valutazione economica in sanità. Questa parte organizza la misurazione dell'intervento nel tempo: serve ex post i criteri della griglia di giudizio, chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione e fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti. ↑

147. Modello di Donabedian per la qualità dell'assistenza: distingue le dimensioni di struttura, processo ed esito, qui integrate dalla dimensione dell'impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società. ↑

148. Batteria di indicatori: circa cinquantotto misure articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti e dai dati del servizio attivo, e circa quaranta richiedono la rilevazione diretta strutturata. ↑
149. Set di esiti essenziali: l'iniziativa COMET e gli standard ICHOM individuano, mediante consenso strutturato (metodo Delphi), un nucleo parsimonioso di esiti da misurare, evitando la proliferazione di misure ridondanti. ↑
150. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline: bisogno e domanda (disponibile), accesso ed equità (da rilevare), processo (parziale, dal servizio attivo), esito clinico (parziale, dal servizio attivo), economici (misto), impatto sociale (misto), organizzativi (da rilevare), variabili di sintesi (da calcolare); i divari tra Aziende Sanitarie Locali sono tra le misure di equità. ↑
151. Protocollo minimo di rilevazione: attivo dal primo giorno, registra la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni, deliberatamente essenziale per non gravare sull'attività clinica; in Piemonte si tratta di strutturare e completare la rilevazione già in atto nel servizio. ↑
152. Strumenti di esito: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9), con punteggio totale da 0 a 27, soglia di rilevanza clinica intorno a 10 e cambiamento affidabile dell'ordine di 6 punti, e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7), impiegati nei soli punteggi complessivi. ↑
153. Modello di misurazione dei programmi inglesi di terapie psicologiche: la raccolta delle misure di esito a ogni seduta, e non solo all'inizio e alla fine, consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non prostrarre percorsi inefficaci. ↑
154. Costituzione della baseline su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti — demografici, epidemiologici, di benessere, di mortalità — forniscono la fotografia del prima, cui in Piemonte si aggiunge il periodo anteriore all'attivazione del 2023 quale base per il confronto prima-dopo; la rilevazione strutturata di servizio completa quella già avviata. ↑
155. Calendario della rilevazione: costituzione della baseline con i dati disponibili e con il periodo pre-attivazione; registrazione corrente; trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale con cadenza mensile; calcolo periodico delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale. ↑
156. Valutazione controfattuale d'impatto: misura l'effetto causale dell'intervento confrontando gli esiti dei trattati con il controfattuale, ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente; poiché il servizio è già attivo in tutte le Aziende Sanitarie Locali, lo strumento non è il dispiegamento scaglionato, ma il confronto prima-dopo l'attivazione del 2023 e l'eterogeneità dell'intensità di copertura tra le aziende, conseguente alla ripartizione a quota capitaria, che insieme configurano l'esperimento naturale. ↑
157. Differenza-nelle-differenze: confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le Aziende Sanitarie Locali a maggiore e a minore intensità di copertura, e prima e dopo l'attivazione del 2023, sotto l'ipotesi di andamento parallelo; vi si affianca il controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata di unità a copertura inferiore. ↑
158. Effetti stimati e validità: l'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e l'effetto medio sui soli trattati; i disegni a esperimento naturale sono, per gli interventi di salute della popolazione, lo strumento raccomandato dalla letteratura metodologica; la validità esterna va valutata a parte. ↑
159. Trasformazione delle stime in prove: confrontando l'andamento, ad esempio, degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche nelle Aziende a maggiore intensità di copertura con quello delle Aziende a copertura inferiore, e prima e dopo l'attivazione del 2023, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata sui dati piemontesi. ↑

160. Verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (VIR; DPCM 169/2017): è valutazione ex post, di norma dopo un biennio, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, che chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva. ↑
161. Clausola valutativa: sul piano regionale, impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti; è il passaggio che lega la misurazione tecnica alla responsabilità politica e alla trasparenza verso il legislatore regionale. ↑
162. Manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi (2008): articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione delle variabili alla normalizzazione, alla ponderazione e all'analisi di robustezza. ↑
163. Benessere Equo e Sostenibile (BES), ISTAT: dodici domini con indici compositi; con la legge n. 163/2016 di riforma del bilancio, una selezione di indicatori è entrata nel ciclo della programmazione economica, a precedente istituzionale dell'impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica. ↑
164. Regole di coerenza e di non duplicazione: il divieto di doppia contabilizzazione impone che, nel medesimo calcolo, una grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali già adottata nella Parte E. ↑
165. Risparmi diretti complessivi per il Servizio sanitario regionale stimati nell'ordine di 16 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 26 nello scenario base e 39 nello scenario espansivo, collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa dell'intervallo. ↑
166. Saldo diretto per il bilancio sanitario, dato dalla differenza tra risparmi diretti e costo del servizio, dell'ordine di -10, -12 e -12 milioni di euro annui nei tre scenari: è lievemente negativo, coerentemente con un saldo di mobilità in equilibrio e con un canale di recupero solo marginale. ↑
167. Il saldo diretto negativo è dichiarato senza attenuazioni e non costituisce una debolezza dell'analisi, ma il suo profilo onesto: a differenza della Puglia, dove il recupero della mobilità passiva concorre al pareggio diretto, in Piemonte il canale della mobilità è solo marginale e il valore dell'intervento risiede in misura preponderante nelle ricadute economico-sociali; tuttavia, in un contesto di pressione finanziaria e di liste di attesa, il contenimento della domanda impropria conserva una salienza diretta non trascurabile. ↑
168. Ritorno sociale: le ricadute economico-sociali comprendono il valore della maggiore produttività recuperata, la riduzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, le efficienze nel sistema dei servizi di salute mentale e il sollievo alle figure di cura familiari. In una regione a popolazione matura e a forte presenza di cronicità, le componenti della produttività recuperata e del sollievo ai familiari hanno un peso particolarmente elevato. ↑
169. Ricadute economico-sociali stimate nell'ordine di 83 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 154 nello scenario base e 240 nello scenario espansivo, secondo i metodi del ritorno sociale sull'investimento, con criteri di stima conservativi. ↑
170. Ritorno complessivo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali, dell'ordine di 99, 180 e 279 milioni di euro annui nei tre scenari; il saldo complessivo, al netto del costo del servizio, è dell'ordine di +73, +142 e +228 milioni di euro annui. ↑
171. Rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,8:1 nello scenario conservativo, 4,7:1 nello scenario base e 5,5:1 nello scenario espansivo, in linea con il valore validato sulle altre regioni e coerente con le stime metodologicamente fondate della letteratura. ↑
172. Caso economico e caso finanziario secondo il Five Case Model: il caso finanziario, riferito al solo bilancio sanitario, presenta un saldo diretto lievemente negativo; il caso economico, riferito alla collettività, è ampiamente positivo. La distinzione tra le due grandezze è la chiave dell'analisi. ↑

173. Sostenibilità finanziaria: il costo del servizio si colloca nell'ordine dello 0,3-0,5% di un Fondo Sanitario Regionale dell'ordine di 9,5 miliardi di euro; benché la regione operi sotto pressione finanziaria, l'importo è contenuto e sostenibile, tanto più che una quota è già a bilancio per il servizio attivo, e l'investimento incrementale è quello necessario a colmare il divario verso il fabbisogno. ↑
174. Lacuna prioritaria: le grandezze economiche qui impiegate sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione (7,2%) e non estratte dai conti regionali certificati; la loro verifica presso le dodici Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliero-Universitarie è condizione per la presentazione alle autorità di finanza pubblica. ↑
175. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 850.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato dall'offerta strutturata attuale; il servizio già attivo ne ha intercettato nel primo anno una quota ancora ridotta, con oltre tremila prese in carico. ↑
176. Modello organizzativo: lo psicologo di base opera nelle Case della Comunità e nei Nuclei delle Cure Primarie, in collaborazione con i medici di medicina generale, secondo protocolli condivisi; nel modello piemontese il servizio è già attivo e ripartito tra le Aziende Sanitarie Locali secondo il criterio della quota capitaria. Come l'Emilia-Romagna, e a differenza del Veneto, il Piemonte non dispone di un'azienda regionale unica: il coordinamento, l'omogeneità attuativa fra le dodici Aziende Sanitarie Locali e le economie di scala sono affidati alla Regione, attraverso la sua Direzione competente, eventualmente affiancata da una cabina di regia regionale. ↑
177. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
178. Percorso clinico: accesso su invio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nella forma già in atto nel servizio regionale, o accesso diretto; valutazione iniziale; ciclo di colloqui brevi; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. ↑
179. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
180. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
181. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
182. ↑
183. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). Questa parte conclusiva applica la griglia di giudizio del telaio, i criteri dell'OCSE-DAC, che attraversano l'intero studio come metro di valutazione e convergono qui nella sintesi; fornisce inoltre il contenuto del caso strategico del Five Case Model. ↑
184. Criteri di valutazione dell'OCSE-DAC (rivisti nel 2019, «Better Criteria for Better Evaluation»): sei lenti complementari — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità — che insieme danno un quadro complessivo dell'intervento. ↑

185. Rilevanza: l'intervento risponde a un bisogno reale e di grande dimensione — dell'ordine di 850.000 persone con disagio comune in larga parte inevaso — e all'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza. ↑
186. Coerenza: l'intervento è compatibile e complementare con gli standard dell'assistenza territoriale (DM 77/2022), con la Missione 6 del PNRR e con gli atti regionali che già ne hanno previsto la funzione — l'attivazione del 2023, i successivi rifinanziamenti e la già approvata legge sulla psicologia scolastica — ed è costituzionalmente difendibile; il Piemonte, pur sotto pressione finanziaria, non è attualmente sottoposto a piano di rientro. ↑
187. Efficacia: l'evidenza internazionale documenta che i modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie raggiungono gli obiettivi clinici, con tassi di recupero dell'ordine del 50% nel programma inglese; i primi dati del servizio piemontese già attivo ne corroborano la praticabilità. ↑
188. Efficienza: l'intervento è favorevole in termini di costo-utilità — con dominanza per paziente e costo-efficacia confermata dall'analisi probabilistica — a fronte, per il Piemonte, di un saldo diretto lievemente negativo sul solo bilancio sanitario, di entità modesta rispetto a un finanziamento dell'ordine di 9,5 miliardi; l'efficienza allocativa è dunque elevata, la convenienza per il solo bilancio lievemente negativa. ↑
189. Impatto: l'impatto distributivo è favorevole, poiché i benefici si concentrano dove l'accesso è più difficile — le aree interne e alpine, l'età anziana e le popolazioni gravate dalle liste di attesa — riducendo il gradiente territoriale; il ritorno complessivo è dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. ↑
190. Sostenibilità: l'intervento è finanziariamente sostenibile — a fronte di un costo modesto, di una pluralità di coperture e di una quota già a bilancio per il servizio attivo — e organizzativamente, in quanto già inserito nella rete territoriale delle Case della Comunità e delle Case della Salute; la leva decisiva della sua durata è l'istituzionalizzazione per legge, che sottrarrebbe il servizio alla precarietà dei rifinanziamenti annuali. ↑
191. Analisi multi-criterio (buone pratiche ISPOR): rende esplicito il bilanciamento dei criteri non riducibili a denaro — l'equità, la fattibilità, la coerenza strategica, la robustezza dell'evidenza — attribuendo a ciascuno un peso e a ciascuna opzione un punteggio. ↑
192. Risultato dell'analisi multi-criterio: su otto criteri pesati, l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 81,75 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri tranne la fattibilità immediata; il sub-punteggio di fattibilità è peraltro più elevato che in altri contesti, poiché il servizio è già attivo, e il risultato è stabile rispetto ai pesi adottati. ↑
193. Le tre affermazioni del cruscotto decisionale per il Piemonte: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, trascurabile rispetto a un finanziamento dell'ordine di 9,5 miliardi, pur con una salienza diretta non nulla nel contesto delle liste di attesa; il ritorno per la collettività è ampio (rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno); il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali. ↑
194. Raccomandazione centrale: la decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già attiva in tutte le dodici Aziende Sanitarie Locali dal 2023, prima e inizialmente unica Regione in Italia — ma se dotarla di una base giuridica stabile, con una legge regionale e un rapporto convenzionale analogo a quello dei medici di medicina generale, e dimensionarla, portandola dalla copertura attuale, dell'ordine del 5% del fabbisogno, alla copertura sistematica, dell'ordine di 700 incarichi nello scenario di base. ↑
195. Cruscotto secondo il Quintuple Aim: la sintesi del valore è letta lungo le cinque dimensioni dell'esito di salute, dell'esperienza, del costo, del benessere degli operatori e dell'equità. ↑
196. Limite principale (radicamento nei dati): le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione piemontese (7,2%), e non estratte dai conti regionali certificati; tale sostituzione è la condizione per la presentazione agli organi di controllo, ed è in Piemonte

agevolata dalla disponibilità dei dati del servizio già attivo. ↑

197. Cautele di trasferibilità e di fonte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la cifra del ritorno è prudenziale e non ponderata per l'equità. ↑
198. Agenda di ricerca: l'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso le dodici Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere-Universitarie, seguito dalla strutturazione della rilevazione di servizio e dalla valutazione controfattuale fondata sul confronto prima-dopo e sull'intensità di copertura. ↑
199. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale; il servizio già attivo ha prodotto nel primo anno dati di attività — oltre tremila pazienti e oltre quindicimila prestazioni — che costituiscono una base preziosa, da consolidare in un flusso strutturato. ↑
200. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑
201. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
202. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
203. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: in Piemonte sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle aree interne e alpine, più anziane e soggette a spopolamento, come il Verbano-Cusio-Ossola e il Biellese; sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza. ↑
204. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
205. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale, con sedi a Vercelli, Novara e Alessandria); post-universitario specialistico (corso regionale con attestato sulla psicologia di base e le cure primarie, comprensivo della competenza per l'età anziana e per le aree interne); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). ↑
206. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. L'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. ↑
207. ↑
208. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. L'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. Questa parte sviluppa i metodi di modellazione e di gestione dell'incertezza del quinto dominio, secondo le buone pratiche di ricerca sulla modellazione dell'ISPOR e dell'Accademia delle scienze, ed è riportata secondo lo standard CHEERS 2022. ↑
209. Modello di Markov a coorte, strumento standard della valutazione economica in sanità: rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi (sintomatico, recupero, cronico, morte), scanditi da cicli con correzione di metà ciclo; la

microsimulazione ne costituisce la variante per le traiettorie individuali. ↑

210. Risultati del caso base (singolo paziente, orizzonte di cinque anni, valori scontati): il braccio dell'intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un'utilità di 3,627 anni di vita ponderati, contro un costo di circa 3.799 euro e un'utilità di 3,392 dell'assistenza usuale; l'intervento è quindi meno costoso (di circa 1.304 euro) e più efficace (di circa 0,236 anni), configurando una dominanza. ↑
211. La dominanza si spiega con la struttura del modello: a fronte di un costo iniziale contenuto, l'intervento accresce il tempo trascorso nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce il tempo trascorso nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte. Il risultato per paziente è il fondamento microeconomico delle stime aggregate della Parte E ed è indipendente dalla regione. ↑
212. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. ↑
213. ↑
214. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudenziale per l'ottimismo delle stime. ↑
215. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
216. Quadro economico consolidato per il Piemonte (Parte E): a regime, da circa 470 a circa 920 psicologi, costo del servizio di 26-51 milioni, risparmi diretti di 16-39 milioni, ricadute sociali di 83-240 milioni; il saldo diretto è lievemente negativo, il saldo complessivo positivo, con rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno. ↑
217. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
218. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio. ↑
219. Valori regionali di ancoraggio per il Piemonte: popolazione di 4.251.868 abitanti (Censimento ISTAT 2024) sostanzialmente stabile e con marcato invecchiamento, finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 9,5 miliardi di euro sotto pressione finanziaria ma senza piano di rientro in atto, saldo di mobilità sostanzialmente in equilibrio e marginalmente negativo, fabbisogno a regime fino a circa 920 psicologi nello scenario espansivo. ↑
220. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione piemontese (7,2%), e non estratti dai conti regionali certificati; i dati da acquisire presso le dodici Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere-Universitarie sono elencati nella tabella seguente, agevolati in Piemonte dalla disponibilità dei dati del servizio già attivo. ↑
221. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑

222. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni agli studi pugliese, lombardo, veneto ed emiliano-romagnolo, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑
223. Analisi di sensibilità a una via: ciascun parametro è fatto variare del 25% in più e in meno, misurandone l'effetto sul beneficio monetario netto; il diagramma a tornado ordina i parametri per influenza, con l'efficacia clinica, i tassi di ricaduta e di cronicizzazione e il costo dello stato cronico tra i più influenti. ↑
224. Incertezza strutturale: oltre all'incertezza dei parametri, l'incertezza sulla struttura e sulle assunzioni del modello è trattata mediante analisi di scenario, e i risultati sono riportati secondo lo standard CHEERS, con validazione della coerenza interna ed esterna. ↑
225. Analisi di sensibilità probabilistica: il modello è eseguito diecimila volte con estrazione casuale dei parametri dalle rispettive distribuzioni (simulazione Monte Carlo), propagando l'incertezza dei parametri sull'incertezza del risultato. ↑
226. Soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, valore di riferimento nella prassi italiana e internazionale. ↑
227. Curva di accettabilità della costo-efficacia: alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è dell'88,9% e la probabilità che sia dominante dell'84,6%; il beneficio monetario netto medio sulle diecimila iterazioni è di circa 7.815 euro per paziente, con intervallo di credibilità al 95% da circa -5.736 a circa +21.501 euro. ↑
228. Distinzione tra costo-utilità e impatto sul bilancio per il Piemonte: la probabilità di costo-efficacia è un risultato di efficienza, riferito al singolo paziente, che valorizza il guadagno di salute e l'intera traiettoria di costo del modello; esso è coerente con il saldo diretto aggregato della Parte E, che per il Piemonte è lievemente negativo, poiché la traduzione dal modello per paziente all'aggregato regionale incorpora le correzioni per peso morto e per l'effettiva monetizzabilità nel bilancio dei costi evitati, e poiché il canale della mobilità è solo marginalmente pertinente, essendo il Piemonte in sostanziale equilibrio di mobilità. L'efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è lievemente negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali. ↑
229. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. ↑
230. ↑
231. Posizione della Liguria: la Regione si è dotata di una legge regionale dedicata, la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20, che all'articolo 76 istituisce il servizio di psicologia territoriale, approvata in sede di legge di stabilità regionale. La legge prevede, presso ciascuna Azienda Sociosanitaria Ligure, un elenco degli psicologi territoriali, almeno due psicologi per distretto sanitario, un rapporto convenzionale su base libero-professionale e la costituzione, da parte della Giunta, di un Osservatorio con funzioni di controllo, programmazione e indirizzo. Sulla base di tale cornice è stata avviata, entro la fine del 2025, una sperimentazione del servizio nelle Case della Comunità, prioritariamente di tipo Hub, con manifestazioni di interesse emanate dalle Aziende per la selezione dei professionisti. ↑
232. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. ↑
233. Priorità di acquisizione: i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso — sono quelli su cui il valore dell'informazione è più elevato e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati alle cinque Aziende

Sociosanitarie Liguri e agli IRCCS. A differenza della Toscana, la Liguria non dispone ancora di propri dati di esito, che la sperimentazione appena avviata produrrà e che andranno consolidati come fonte primaria di calibrazione. ↑

234. Verifica empirica: poiché la sperimentazione è in fase di avvio e si dispiega progressivamente tra le cinque Aziende e i loro distretti, la verifica può poggiare su un disegno a cunei progressivi pianificato prospetticamente — il più pulito tra quelli realizzabili nella serie regionale — oggetto della Parte L, che riduce l'incertezza sostituendo progressivamente le stime con misure osservate sui dati liguri via via che il servizio si estende. ↑
235. Disagio giovanile: è una componente rilevante e in crescita, con fenomeni di ansia e disagio tra gli adolescenti che solo in parte trovano risposta nei servizi; la quota intercettata rappresenta presumibilmente una frazione del bisogno reale. ↑
236. Salute mentale connessa al lavoro: nella popolazione attiva, ampia parte dei lavoratori è esposta a fattori di stress correlati al lavoro; l'intercettazione precoce del disagio ha un valore particolarmente elevato in termini di produttività recuperata. ↑
237. Bisogno dell'età anziana: la domanda connessa all'invecchiamento, alla cronicità e alla comorbidità psicologica delle patologie croniche è il tratto più caratteristico del fabbisogno ligure, nella regione più anziana d'Italia, ed è ulteriormente accentuato nell'entroterra appenninico, più anziano e a maggiore difficoltà di accesso. ↑
238. Tratto distintivo della Liguria rispetto alle altre regioni: la combinazione dell'invecchiamento più marcato d'Italia, della più alta prevalenza nazionale di utenti trattati dai servizi di salute mentale e della condizione di Regione che ha già istituito il servizio con una legge dedicata ma ne ha appena avviato la sperimentazione; il bisogno è quindi accompagnato da una base giuridica già acquisita, ma da un'esperienza operativa ancora ai primi passi, da condurre a regime. ↑
239. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche elevati: dell'ordine di ventimila l'anno, con un tasso (13,7 per mille abitanti) superiore alla media nazionale; elevati risultano anche i dimessi dai reparti di psichiatria e le riammissioni a trenta giorni, indici di una pressione sul sistema acuto che un primo livello territoriale efficace potrebbe in parte contenere a monte. ↑
240. Offerta territoriale: la Liguria ha istituito il servizio di psicologia territoriale con la legge regionale 20 del 2023 (articolo 76) e ne ha avviato la sperimentazione entro la fine del 2025, prioritariamente nelle Case della Comunità di tipo Hub e in integrazione con la medicina generale. La sperimentazione è però dimensionata, in prima applicazione, a trentotto psicologi territoriali su base libero-professionale, con manifestazioni di interesse emanate dalle Aziende per la selezione dei professionisti, e copre una frazione minima del fabbisogno. ↑
241. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 330 psicologi (intervallo 310-350). L'Ordine degli Psicologi della Liguria, che ha accompagnato l'iter della legge e l'avvio della sperimentazione, ne sostiene la conduzione a regime con un rapporto convenzionale stabile, a superamento della fase di prima applicazione. ↑
242. Copertura attuale del fabbisogno minima: il servizio è istituito per legge ma la sperimentazione è appena avviata, dimensionata a trentotto psicologi, dell'ordine del tre-quattro per cento del fabbisogno potenziale; la distanza dalla copertura adeguata è quindi ampia, e la decisione verte sul colmarla. ↑
243. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante in Liguria è quello fra la fascia costiera, dove si concentrano la popolazione e i poli sanitari, e l'entroterra appenninico, anziano, disperso e in spopolamento, dove l'accesso ai servizi è reso difficile dalla conformazione vallata; a esso si aggiunge la pressione delle

liste di attesa. La telepsicologia assistita è lo strumento per avvicinare l'offerta alle aree interne, dove la sola presenza di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio. ↑

244. Finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 3,5 miliardi di euro; la Liguria non è soggetta a un piano di rientro, ma presenta un disavanzo strutturale coperto con risorse regionali e opera sotto pressione finanziaria, con la riduzione delle liste di attesa indicata come priorità e con un Piano Socio Sanitario 2023-2025 di riferimento; il ricorso al privato accreditato è tra i più contenuti d'Italia. ↑
245. Mobilità sanitaria a saldo passivo, dell'ordine di settanta milioni di euro e in peggioramento negli ultimi anni, con una mobilità passiva ospedaliera concentrata nelle specialità chirurgiche — ortopedia (44%), cardiologia e malattie del sistema nervoso. La Regione ha varato nel 2025 un piano dedicato per ridurla. Poiché la fuga riguarda la chirurgia e non la domanda psicologica delle cure primarie, il canale del recupero della mobilità, centrale per le regioni debitrici del Mezzogiorno, in Liguria è solo marginalmente pertinente a questo intervento. ↑
246. Cornice normativa e programmatica: la Liguria dispone di una legge regionale dedicata, l'articolo 76 della legge 20 del 2023, che istituisce il servizio di psicologia territoriale, prevede elenchi aziendali, un rapporto convenzionale e la costituzione di un Osservatorio, e ammette in prima applicazione gli psicologi con esperienza almeno biennale. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale; sul piano nazionale, il testo unificato C. 1140, il Piano Nazionale per la Salute Mentale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 sulla competenza regionale. A differenza di altre regioni, in Liguria una legge regionale dedicata è già vigente, ma la sua attuazione è ai primi passi. ↑
247. Popolazione residente in Liguria 1.510.143 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 2,6% della popolazione nazionale, in lievissimo aumento rispetto all'anno precedente (+0,1%); tale incremento è dovuto interamente al saldo migratorio, estero e interno, che compensa un saldo naturale fortemente negativo (– 12.692 unità), tanto che, senza le migrazioni, la popolazione sarebbe diminuita di oltre dodicimila residenti. Più della metà della popolazione risiede nella sola Città Metropolitana di Genova (54,2%); seguono le province di Savona, La Spezia e Imperia. Il territorio si distende su una stretta fascia costiera e su un entroterra appenninico a forte spopolamento, con i comuni più piccoli tra i più anziani d'Italia. ↑
248. ↑
249. Popolazione residente in Liguria 1.510.143 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 2,6% della popolazione nazionale, in lievissimo aumento rispetto all'anno precedente (+0,1%); tale incremento è dovuto interamente al saldo migratorio, estero e interno, che compensa un saldo naturale fortemente negativo (– 12.692 unità), tanto che, senza le migrazioni, la popolazione sarebbe diminuita di oltre dodicimila residenti. Più della metà della popolazione risiede nella sola Città Metropolitana di Genova (54,2%); seguono le province di Savona, La Spezia e Imperia. Il territorio si distende su una stretta fascia costiera e su un entroterra appenninico a forte spopolamento, con i comuni più piccoli tra i più anziani d'Italia. Questa parte copre l'ottavo dominio del modello HTA, il profilo del paziente e sociale, e risponde al criterio di impatto della griglia di giudizio; l'equità è trattata come dimensione costitutiva della valutazione, secondo l'evoluzione che ha affiancato l'equità in salute agli obiettivi di esito, esperienza e costo. ↑
250. Gradiente sociale della salute mentale: le popolazioni in deprivazione presentano prevalenze più elevate di disturbi mentali comuni e un accesso più difficile ai servizi. In Liguria il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato, sicché il gradiente socio-economico non è il tratto distintivo dell'equità; prevalgono tre dimensioni diverse: la dualità fra la fascia costiera, densa e ben servita, e l'entroterra appenninico, anziano, disperso e in spopolamento; l'invecchiamento della popolazione, il più marcato d'Italia; e una dimensione multiculturale non trascurabile, con una componente straniera intorno all'undici per cento. ↑

251. La gratuità, la prossimità e l'assenza di stigma del servizio di primo livello abbattano le barriere economiche, geografiche e culturali che gravano in misura maggiore sulle popolazioni svantaggiate; in Liguria rilevano in particolare l'abbattimento della barriera geografica nell'entroterra appenninico, dove la conformazione vallata e montana e la distanza dai servizi sono il principale ostacolo, integrato dalla telepsicologia, e l'abbattimento della barriera culturale e linguistica per l'utenza straniera. ↑
252. Variabili di equità, accesso e protezione finanziaria seguite dallo studio: riduzione dei tempi di attesa per l'accesso psicologico, accessibilità geografica nell'entroterra appenninico, accessibilità culturale e linguistica, equità di esito tra gruppi, equità di genere, accesso per l'età anziana, per i gruppi fragili e le persone con disabilità, gratuità per i gruppi vulnerabili, copertura del bisogno non soddisfatto. ↑
253. Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA), secondo Cookson, Asaria e colleghi: estende la valutazione economica alla dimensione dell'equità, stimando come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l'effetto sulle disuguaglianze, mediante anni di vita ponderati per l'equità, indice di concentrazione e indici di disuguaglianza assoluta e relativa. ↑
254. Direzione del risultato distributivo: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove l'accesso è oggi più difficile — l'entroterra appenninico, l'età anziana, l'utenza straniera e i gruppi gravati dalle liste di attesa — i benefici dell'intervento si concentrano sui gruppi più svantaggiati nell'accesso, riducendo il gradiente territoriale negli esiti di salute mentale; l'intervento migliora l'esito medio e ne comprime al tempo stesso la disuguaglianza. ↑
255. Ponderazione distributiva: l'attribuzione di pesi maggiori ai benefici che ricadono sui più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, come riferimento conservativo, il rapporto beneficio-costi non ponderato già esposto nella Parte E, dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. In Liguria, ove la popolazione non è prevalentemente deprivata, l'effetto della ponderazione sarebbe più contenuto che nel Mezzogiorno, il che rende la scelta non ponderata tanto più prudente. ↑
256. Algoritmo allocativo quale meccanismo operativo dell'equità: la distribuzione territoriale degli incarichi non segue la sola popolazione, ma pondera ciascun distretto per l'indice di vecchiaia, l'indice di deprivazione socioeconomica, la prevalenza di cronicità e multimorbidità e la presenza straniera, attribuendo pesi maggiori all'entroterra appenninico e ai comuni più anziani; in Liguria l'indice di vecchiaia — il più elevato d'Italia — è il fattore di ponderazione di gran lunga prevalente. ↑
257. Indice di deprivazione multipla: misura sintetica costruita su reddito, occupazione, istruzione, salute, condizione abitativa e ambiente, impiegata per individuare le aree prioritarie nell'allocazione degli incarichi. ↑
258. Divari territoriali in Liguria: il divario rilevante non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra la fascia costiera, dove si concentrano la popolazione e i poli sanitari, e l'entroterra appenninico, a popolazione anziana e dispersa e in spopolamento, dove i comuni più piccoli presentano un'età media superiore ai cinquantuno anni. In queste aree la sola presenza fisica di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio, integrato dalla telepsicologia. ↑
259. Liste di attesa, uniformità del servizio e aree interne quali dimensioni di equità: in Liguria, dove il canale della mobilità recuperata è solo marginalmente pertinente perché la fuga è chirurgica, le principali leve distributive sono la riduzione delle liste di attesa, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato, l'estensione uniforme del servizio dalla sperimentazione appena avviata a tutte le Case della Comunità delle cinque Aziende, e l'accesso nell'entroterra appenninico. ↑
260. Protezione finanziaria: il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata diretta per la psicoterapia, l'impovertimento connesso alle cure e le spese sanitarie catastrofiche, con beneficio maggiore per i redditi bassi, per i quali la psicoterapia privata è spesso inaccessibile. ↑

261. Copertura del bisogno non soddisfatto come equità: intercettare la quota inevasa del disagio — dell'ordine di 300.000 persone, in larga parte non intercettata — significa raggiungere proprio coloro che hanno minore probabilità di accedere spontaneamente ai servizi, in una regione che peraltro registra già la più alta prevalenza nazionale di utenti dei servizi specialistici. ↑
262. Collegamento al monitoraggio: gli indicatori di equità — accesso per area e per livello socio-economico, accesso dell'età anziana e dell'utenza straniera, gradiente dell'esito, tempi di attesa per area — fanno parte del sistema di indicatori della Parte L, e consentono di accertare nel tempo se il servizio raggiunga le comunità dell'entroterra più distanti e i gruppi più fragili. ↑
263. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; condizione attuale come comparatore. ↑
264. ↑
265. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; condizione attuale come comparatore. Metodo della revisione: la sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche (PRISMA 2020) e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE; sono considerati studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. ↑
266. Studio fondativo del modello collaborativo (IMPACT), pubblicato su JAMA nel 2002: circa il 50% dei pazienti trattati ha conseguito una riduzione di almeno il 50% dei sintomi a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. ↑
267. Meta-analisi su cinquantasette studi controllati (2012): l'integrazione della cura ha prodotto un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard rispetto alla cura usuale. ↑
268. Revisione di quarantadue implementazioni del modello (2024): riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 43% dell'ansia a sei mesi, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. ↑
269. Programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies), dati reali 2023-2024: tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile del 67,8% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su una scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno. ↑
270. Meta-analisi sulle cure integrate: coefficiente standardizzato dell'ordine di -0,11 sui sintomi depressivi, di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante quando applicato a una popolazione ampia. ↑
271. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. ↑
272. Cautela metodologica rilevante: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi (l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero); il valore economico del modello poggia in misura preponderante sui ritorni sociali, non sui risparmi sanitari diretti. Questa cautela è coerente con il profilo del caso economico ligure, fondato anch'esso sulle ricadute sociali. ↑
273. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. ↑

274. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. ↑
275. ↑
276. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. Questa parte copre tre domini del modello HTA — il profilo etico (dominio 6), il profilo organizzativo (dominio 7) e il profilo giuridico (dominio 9) — che completano la valutazione oltre i piani già trattati. ↑
277. Profilo etico: le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato; la persona resta il soggetto, e mai l'oggetto, della presa in carico. ↑
278. Consenso informato: è modulare, prestato distintamente per i diversi trattamenti, e reso anche in forma digitale; nella salute mentale i dati sono ultrasensibili, sicché la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi possa accedervi. ↑
279. Conduzione etica della valutazione: gli esiti sono resi pubblici indipendentemente dal loro segno, a garanzia contro la distorsione da selezione dei risultati favorevoli, e l'intero impianto è sottoposto all'approvazione del comitato etico territorialmente competente. ↑
280. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante, senza che ne siano registrate le modalità. ↑
281. Articolo 32 della Costituzione e legge 23 dicembre 1978, n. 833: la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, e il Servizio sanitario nazionale fondato su universalità, eguaglianza ed equità. ↑
282. Articolo 117, terzo comma, della Costituzione: la tutela della salute è materia di competenza concorrente, nella quale allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio e l'organizzazione del servizio; la Liguria ha esercitato tale competenza nella forma più piena, approvando una legge regionale dedicata che istituisce il servizio, e non con un mero atto amministrativo. ↑
283. Articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è la leva attraverso cui un'eventuale legge statale potrebbe ricondurre la psicologia di base tra le prestazioni garantite in modo uniforme su tutto il territorio. ↑
284. Corte costituzionale, sentenza 13 dicembre 2021, n. 241: pronunciandosi su una legge regionale, ha tracciato il confine della competenza in materia, ritenendo legittima l'organizzazione del servizio che si avvalga di professionisti già esistenti nel quadro dell'assistenza territoriale, ma riconducendo allo Stato la determinazione dei livelli essenziali e la disciplina dei rapporti di lavoro. La legge ligure opera mediante un rapporto convenzionale modellato su quelli già vigenti e si colloca pertanto nello spazio legittimo, ma il suo consolidamento pieno e l'estensione uniforme tra le regioni restano affidati alla legge statale. ↑
285. Base giuridica regionale della Liguria: il servizio è istituito dall'articolo 76 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20, che prevede elenchi aziendali di psicologi territoriali, almeno due psicologi per distretto, un rapporto convenzionale su base libero-professionale e la costituzione di un Osservatorio, ammettendo in prima applicazione gli psicologi con esperienza almeno biennale; in attuazione è stata avviata la sperimentazione, dimensionata a trentotto psicologi. A differenza del Veneto, la Liguria non dispone di un'azienda regionale unica, e la cornice di coordinamento è costituita dalla Regione, dalle cinque Aziende e dall'Azienda Ligure Sanitaria. La decisione non verte sul prevedere la funzione né sul dotarla di una legge, già esistente, ma sul condurla dalla sperimentazione alla strutturazione a regime e sul dimensionarla. ↑

286. Vincolo di destinazione delle risorse: il principio per cui i fondi del Servizio sanitario devono essere destinati alla garanzia dei livelli essenziali è rispettato dalla riforma, di costo contenuto e relativa a un servizio di primo livello delle cure primarie. La Liguria non è sottoposta a piano di rientro, ma presenta un disavanzo strutturale coperto con risorse regionali ed è debitrice nella mobilità; l'investimento incrementale necessario alla strutturazione a regime, contenuto, è coerente con tale principio. ↑
287. Deontologia professionale: il servizio opera nel rispetto delle norme deontologiche della professione, sotto la vigilanza dell'Ordine degli Psicologi della Liguria, che ha accompagnato l'iter della legge e l'avvio della sperimentazione e concorre alla governance e alla formazione, e che riunisce gli oltre tremila professionisti iscritti nella regione. ↑
288. Responsabilità clinica e ruolo dell'IA: l'impiego dell'intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali — il medico di medicina generale resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell'intervento psicologico, e l'IA è assimilata a un dispositivo di supporto, non a una figura che compie atti — sicché non si introduce una nuova figura professionale, ma uno strumento che assiste quelle esistenti. ↑
289. Conformità degli strumenti di IA: il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, in vigore dal 2025, classifica come ad alto rischio i sistemi impiegati nei dispositivi medici, con obblighi differiti oltre il 2027; il regolamento sui dispositivi medici impone la marcatura CE; il regolamento sulla protezione dei dati ne disciplina il trattamento; vi si innestano la supervisione umana costante, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias, la trasparenza e il divieto di discriminazione algoritmica. ↑
290. Equità digitale: per non generare nuove disuguaglianze, sono previsti canali tradizionali paralleli per chi non dispone di strumenti digitali — segnatamente le persone anziane dell'entroterra appenninico — e il supporto multilingue per la popolazione straniera, ferma restando la garanzia dell'alternativa in presenza. ↑
291. Protezione dei dati: misure di sicurezza robuste — crittografia e pseudonimizzazione per le analisi — consenso modulare anche in forma digitale, collaborazione con l'Autorità garante e acquisizione di software dotati di marcatura adeguata secondo le normali procedure. ↑
292. Benchmark statunitense (Collaborative Care): modello a équipe integrata, validato da oltre novanta studi controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri. ↑
293. Esperienze italiane: le sperimentazioni locali, fra cui quelle riconducibili al modello di Solano nel Lazio, anticipano l'integrazione psicologica nelle cure primarie; ad esse si aggiungono oggi i servizi avviati nelle regioni che si sono dotate di una legge dedicata, tra cui la Liguria con la legge regionale 20 del 2023. I dati delle sperimentazioni storiche derivano però da campioni limitati e in parte da letteratura grigia, e vanno assunti con la dovuta cautela. ↑
294. Trasferibilità: i risultati internazionali provengono da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale; la loro trasposizione richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche. ↑
295. Evidenza locale ligure: a differenza della Toscana, dove una sperimentazione già matura fornisce dati di esito reale, in Liguria la sperimentazione è appena avviata e non ha ancora prodotto dati propri; l'evidenza locale è quindi, allo stato, prospettica, e dovrà essere costruita sistematicamente man mano che il servizio si dispiega. Ne consegue che lo studio poggia, per l'efficacia, in misura maggiore sui benchmark internazionali e sul disegno valutativo, e in misura minore su dati italiani già disponibili. ↑
296. Condizioni liguri per la trasferibilità e la valutazione: pur non disponendo ancora di dati operativi propri, la Liguria presenta un terreno favorevole alla valutazione rigorosa, costituito dall'infrastruttura informatica regionale, dalla rete delle Case della Comunità e dal coordinamento dell'Azienda Ligure Sanitaria; il

vantaggio peculiare della regione è di poter disegnare la valutazione fin dall'avvio del servizio, anziché ricostruirla a posteriori, così da generare un'evidenza locale solida e non soltanto importata. ↑

297. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative: il rapporto di 4:1 spesso citato e l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio sono semplificazioni a fini divulgativi; lo stesso vale per il rapporto di 2,5:1 talvolta richiamato in ambito regionale. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costo complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8:1-5,5:1. ↑
298. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. La Liguria presenta un saldo di mobilità sanitaria passivo, dell'ordine di settanta milioni di euro, in peggioramento negli ultimi anni; tuttavia la fuga è concentrata nelle specialità chirurgiche — ortopedia, cardiologia e malattie del sistema nervoso — e non nella domanda psicologica delle cure primarie. Ne consegue che il canale del recupero della mobilità, leva centrale per le regioni debitrice del Mezzogiorno come la Puglia, in Liguria è solo marginalmente pertinente a questo intervento, che agisce su un bisogno diverso. Il saldo diretto risulta pertanto lievemente negativo e il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi; in un contesto di pressione finanziaria e di primato nazionale della domanda di salute mentale, il contenimento della domanda impropria assume comunque una salienza diretta. ↑
299. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (2,6%) e non estratti dai conti regionali certificati delle cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, degli IRCCS San Martino e Gaslini e degli enti ospedalieri: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare prima della presentazione esterna. A differenza della Toscana, dove la sperimentazione già matura fornisce dati operativi reali, in Liguria tale mitigazione è ancora limitata, poiché la sperimentazione è appena avviata e i suoi dati di esito devono ancora maturare. ↑
300. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
301. Valutazione controfattuale d'impatto: poiché la sperimentazione è in fase di avvio e si dispiega progressivamente tra le cinque Aziende e i loro distretti, la Liguria offre l'occasione, più netta che in ogni altra regione della serie, di disegnare prospetticamente un esperimento a cunei progressivi propriamente detto, in cui l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi sono definiti in anticipo e secondo criteri trasparenti. L'effetto causale è stimato con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico, confrontando le sedi attivate prima con quelle attivate dopo e sfruttando l'eterogeneità dell'intensità di copertura; l'Osservatorio previsto dalla legge regionale ne costituisce la sede di governo. ↑
302. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione, cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa), IRCCS Policlinico San Martino e IRCCS Istituto Gaslini, enti ospedalieri Galliera ed Evangelico, Ordine degli Psicologi della Liguria, rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e Università di Genova — nonché dall'Osservatorio previsto dalla legge regionale. A differenza del Veneto, la Liguria non dispone di un'azienda regionale unica, ma l'Azienda Ligure Sanitaria svolge funzioni regionali di coordinamento, programmazione e governo del sistema; con una legge già vigente e una sperimentazione appena avviata, la sfida del governo è condurre a regime e dimensionare un servizio già istituito, definendone l'ordine di attivazione tra le Aziende. ↑
303. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑

304. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
305. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. ↑
306. ↑
307. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Questa parte copre il settimo dominio del modello HTA, il profilo organizzativo, e fornisce il contenuto del caso commerciale e del caso gestionale del Five Case Model, rispondendo al criterio di sostenibilità. ↑
308. Modello RE-AIM: misura la riuscita e la validità esterna dell'attuazione lungo cinque dimensioni — la portata, l'efficacia, l'adozione, l'implementazione e il mantenimento; per la Liguria sono dirimenti l'adozione, che muove ora i primi passi con la sperimentazione, e il mantenimento, ossia il consolidamento a regime di un servizio appena avviato. ↑
309. Quadro consolidato per la ricerca sull'implementazione (CFIR): spiega i determinanti dell'attuazione, articolati in cinque domini — le caratteristiche dell'innovazione, il contesto esterno, il contesto interno, gli individui coinvolti e il processo di attuazione — consentendo l'individuazione ex ante di barriere e facilitatori. ↑
310. Determinanti di implementazione seguiti dallo studio: il tasso di copertura, il grado di adozione delle sedi, la fedeltà al modello, i tempi di dimensionamento, il numero di psicologi reclutati e formati, la qualità della formazione e della supervisione, il grado di integrazione nei flussi di lavoro, l'aderenza ai percorsi e la scalabilità. ↑
311. Disegno del dimensionamento in Liguria: poiché la sperimentazione è appena avviata e dimensionata a trentotto psicologi, dell'ordine del tre-quattro per cento del fabbisogno, il dispiegamento muove essenzialmente dall'inizio e consiste nell'estensione progressiva della copertura a tutte le Case della Comunità e ai distretti delle cinque Aziende verso il regime, per fasi semestrali e a partire dalle sedi di maggiore prontezza, sotto il coordinamento dell'Azienda Ligure Sanitaria e secondo criteri trasparenti. ↑
312. Doppia funzione del dimensionamento progressivo: esso risponde a un'esigenza organizzativa — accrescere la copertura in modo graduale, compatibile con i tempi del reclutamento e della formazione — e al tempo stesso, definendo prospetticamente l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi, fonda la valutazione controfattuale d'impatto a cunei progressivi, la più pulita realizzabile nella serie regionale, oggetto della Parte L. ↑
313. Reclutamento: a fronte di un fabbisogno a regime dell'ordine di 330 psicologi, il reclutamento avviene tramite l'iscrizione a un elenco istituito presso ciascuna Azienda e l'instaurazione di un rapporto convenzionale, con requisiti di iscrizione all'albo e di formazione specifica; in prima applicazione la legge regionale valorizza i professionisti con esperienza almeno biennale, e il bacino è ampio, contando la regione oltre tremila psicologi iscritti all'Ordine. ↑
314. Cronoprogramma: il dimensionamento procede per fasi semestrali, accrescendo progressivamente la copertura in tutte le Aziende; le attività di reclutamento, formazione e consolidamento sono condotte in modo graduale, mentre il monitoraggio e la valutazione accompagnano l'intero arco e proseguono oltre il raggiungimento del regime. ↑

315. Soglia di riuscita: tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% nella fase di dimensionamento, a fronte del valore di riferimento del programma inglese; il monitoraggio è chiamato a verificarne il raggiungimento sui dati liguri, che la sperimentazione appena avviata inizierà a produrre. ↑
316. Caso commerciale (Five Case Model): la fattibilità dell'assetto contrattuale poggia sul rapporto convenzionale su base libero-professionale previsto dalla legge regionale, da cui un costo medio per incarico dell'ordine di 55.000 euro l'anno e gli scenari di spesa di 9, 14 e 18 milioni già esposti nella Parte E; le manifestazioni di interesse per la selezione dei professionisti sono già state emanate dalle Aziende, e il nodo specifico della Liguria è la stabilizzazione progressiva del rapporto verso un assetto convenzionale a regime, senza creazione di nuove figure. ↑
317. Caso gestionale (Five Case Model): l'attuazione è governata su due livelli. A livello regionale, un comitato di indirizzo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, le cinque Aziende, l'Azienda Ligure Sanitaria, gli IRCCS San Martino e Gaslini, gli enti ospedalieri Galliera ed Evangelico, l'Ordine degli Psicologi della Liguria, la medicina generale, la pediatria di libera scelta e l'Università di Genova, affiancato dall'Osservatorio previsto dalla legge; a livello aziendale, ciascuna Azienda è responsabile dell'attuazione nel proprio ambito. A differenza del Veneto, la Liguria non dispone di un'azienda regionale unica, ma l'Azienda Ligure Sanitaria assicura il coordinamento. ↑
318. Rischi attuativi e misure di mitigazione: il rischio più specifico della Liguria è la fragilità di una sperimentazione appena avviata e di dimensione minima, dipendente dal finanziamento iniziale; ad esso si aggiungono il reclutamento insufficiente, la debole adesione della medicina generale e l'interoperabilità incompleta dei sistemi informativi. Poiché la legge è già vigente, la principale misura di mitigazione è la conduzione a regime con un rapporto convenzionale stabile e un dimensionamento graduale, che consente di osservare, correggere e adattare fin dalle prime fasi. ↑
319. Caso finanziario e coperture (Five Case Model): le fonti di copertura comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, dell'ordine di 3,5 miliardi di euro, di cui una quota è già destinata alla sperimentazione avviata, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'infrastruttura territoriale e digitale, e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali. ↑
320. Vincoli di bilancio: la Liguria opera sotto pressione finanziaria, con un disavanzo strutturale coperto con risorse regionali e una mobilità passiva, pur non essendo in piano di rientro; il costo del servizio, anche a massima copertura, costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale del finanziamento, ed essendone già a bilancio una quota, l'investimento incrementale è quello necessario a colmare il divario verso il fabbisogno, sostenibile a condizione di prudenza nella programmazione. ↑
321. Sostenibilità nel tempo (criterio OCSE-DAC): per la Liguria la leva decisiva della sostenibilità non è l'istituzionalizzazione per legge, già acquisita, né la maturità operativa, ancora da costruire, ma la conduzione a regime con un rapporto convenzionale stabile e un dimensionamento adeguato, che sottrarrebbe il servizio alla fragilità della fase di avvio; vi concorrono la modestia del costo rispetto al bilancio, il forte ritorno sociale documentato e il coordinamento regionale dell'Azienda Ligure Sanitaria. ↑
322. Nota di cautela metodologica: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la verifica empirica sui dati liguri, prevista dalla Parte L e fondata su un disegno a cunei progressivi pianificato fin dall'avvio, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate. ↑
323. Aspettativa di vita alla nascita dell'ordine degli ottantuno anni per gli uomini e degli ottantacinque per le donne, in linea con la media nazionale; la struttura per età è la più anziana d'Italia, con l'indice di vecchiaia più elevato del Paese (dell'ordine di 277 anziani ogni cento giovani), una quota di ultrasessantacinquenni

intorno al ventinove per cento e una di giovani sotto i quindici anni tra le più basse; Genova è tra le aree più anziane d'Europa. ↑

324. Componente straniera dell'ordine del 10,8% dei residenti (163.189 persone), superiore alla media nazionale, con prevalenza di cittadinanze albanese, romena e marocchina e un'incidenza provinciale compresa tra il 9,3% di Savona e il 14,5% di Imperia; sono proprio i flussi migratori, estero e interno, a sostenere la popolazione e a frenarne l'invecchiamento, compensando un saldo naturale strutturalmente negativo. ↑
325. Articolazione del territorio in quattro province: più della metà dei residenti vive nella sola Città Metropolitana di Genova (54,2%), l'unica a superare i cinquecentomila abitanti; seguono le province di Savona (17,7%), La Spezia (14,2%) e Imperia (13,9%). ↑
326. Profilo territoriale a marcata variabilità interna: la popolazione si distende su una stretta fascia costiera e su un entroterra appenninico a forte spopolamento, dove i comuni più piccoli presentano un'età media superiore ai cinquantuno anni e un invecchiamento ancora più accentuato della media regionale, con difficoltà di accesso ai servizi acute dalla conformazione vallata e montana. ↑
327. ↑
328. Profilo territoriale a marcata variabilità interna: la popolazione si distende su una stretta fascia costiera e su un entroterra appenninico a forte spopolamento, dove i comuni più piccoli presentano un'età media superiore ai cinquantuno anni e un invecchiamento ancora più accentuato della media regionale, con difficoltà di accesso ai servizi acute dalla conformazione vallata e montana. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Dipartimenti di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. ↑
329. ↑
330. Profilo territoriale a marcata variabilità interna: la popolazione si distende su una stretta fascia costiera e su un entroterra appenninico a forte spopolamento, dove i comuni più piccoli presentano un'età media superiore ai cinquantuno anni e un invecchiamento ancora più accentuato della media regionale, con difficoltà di accesso ai servizi acute dalla conformazione vallata e montana. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Dipartimenti di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Identificazione dei costi: il costo del servizio comprende le remunerazioni dei psicologi, i costi organizzativi e di coordinamento e la quota destinata alla formazione congiunta; è stimato per scenario di copertura ed espresso a regime. ↑
331. Costo del servizio per scenario, a regime: dell'ordine di 9 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 14 nello scenario base e 18 nello scenario espansivo, valori coerenti con l'inclusione del programma di formazione all'intelligenza artificiale. ↑
332. Metodo di stima del costo: il valore unitario per incarico è dell'ordine di 55.000 euro annui; la stima è regionalizzata in proporzione alla popolazione (2,6% del totale nazionale) e al numero di professionisti. La sperimentazione è oggi finanziata su base libero-professionale per un importo dell'ordine di due milioni di euro, che copre una frazione minima del fabbisogno, dell'ordine del tre-quattro per cento. ↑
333. Identificazione e misura degli esiti: gli esiti di salute sono espressi in anni di vita ponderati per la qualità e in esiti clinici validati; i tassi di recupero e di miglioramento sono desunti dai benchmark consolidati e applicati in via prudenziale. ↑
334. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi (questionario a nove voci sui sintomi depressivi e scala a sette voci per il disturbo d'ansia); tasso di recupero di riferimento dell'ordine del 50%. ↑

335. Costo-efficacia e costo-utilità: il costo per anno di vita ponderato per la qualità si colloca al di sotto della soglia comunemente adottata; l'analisi per paziente, sviluppata nella Parte F, indica condizioni di dominanza dell'intervento rispetto all'opzione di non intervento. ↑
336. Soglia di costo-efficacia di riferimento dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, coerente con la prassi internazionale della valutazione economica in sanità. ↑
337. ↑
338. Soglia di costo-efficacia di riferimento dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, coerente con la prassi internazionale della valutazione economica in sanità. Questa parte organizza la misurazione dell'intervento nel tempo: serve ex post i criteri della griglia di giudizio, chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione e fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti. ↑
339. Modello di Donabedian per la qualità dell'assistenza: distingue le dimensioni di struttura, processo ed esito, qui integrate dalla dimensione dell'impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società. ↑
340. Batteria di indicatori: circa cinquantotto misure articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti, mentre la quota che in altre regioni proviene dalla sperimentazione già matura va in Liguria interamente rilevata, poiché la sperimentazione è appena avviata; circa quaranta misure richiedono pertanto la rilevazione diretta strutturata, progettabile fin dall'inizio. ↑
341. Set di esiti essenziali: l'iniziativa COMET e gli standard ICHOM individuano, mediante consenso strutturato (metodo Delphi), un nucleo parsimonioso di esiti da misurare, evitando la proliferazione di misure ridondanti. ↑
342. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline: bisogno e domanda (disponibile), accesso ed equità (da rilevare), processo (da rilevare), esito clinico (da rilevare), economici (misto), impatto sociale (misto), organizzativi (da rilevare), variabili di sintesi (da calcolare); i divari tra le cinque Aziende sono tra le misure di equità, accanto al divario costa-entroterra. ↑
343. Protocollo minimo di rilevazione: attivo dal primo giorno, registra la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni, deliberatamente essenziale per non gravare sull'attività clinica; in Liguria, poiché la sperimentazione è appena avviata, il protocollo può essere disegnato fin dall'inizio in forma completa e uniforme, anziché strutturare a posteriori una rilevazione già in corso. ↑
344. Strumenti di esito: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9), con punteggio totale da 0 a 27, soglia di rilevanza clinica intorno a 10 e cambiamento affidabile dell'ordine di 6 punti, e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7), impiegati nei soli punteggi complessivi. ↑
345. Modello di misurazione dei programmi inglesi di terapie psicologiche: la raccolta delle misure di esito a ogni seduta, e non solo all'inizio e alla fine, consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non protrarre percorsi inefficaci. ↑
346. Costituzione della baseline su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti — demografici, epidemiologici, di benessere, di mortalità — forniscono la fotografia del prima; e poiché in Liguria il servizio si dispiega essenzialmente dall'inizio, il periodo anteriore all'attivazione costituisce per tutte le cinque Aziende una base di confronto particolarmente pulita, completata dalla rilevazione strutturata di servizio. ↑
347. Calendario della rilevazione: costituzione della baseline con i dati disponibili e con il periodo pre-attivazione; registrazione corrente; trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale e all'Osservatorio con cadenza mensile; calcolo periodico delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale. ↑

348. Valutazione controfattuale d'impatto: misura l'effetto causale dell'intervento confrontando gli esiti dei trattati con il controfattuale, ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente; poiché in Liguria la sperimentazione è appena avviata e si dispiega progressivamente tra le cinque Aziende e i loro distretti, lo strumento è un vero disegno a cunei progressivi pianificato prospetticamente — il più pulito realizzabile nella serie regionale — nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi sono stabiliti in anticipo a fini valutativi, e non ricostruiti a posteriori. ↑
349. Differenza-nelle-differenze: confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le sedi e i distretti attivati prima e quelli attivati dopo, e a maggiore e minore intensità di copertura, sotto l'ipotesi di andamento parallelo; vi si affianca il controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata delle sedi non ancora attivate. ↑
350. Effetti stimati e validità: l'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e l'effetto medio sui soli trattati; i disegni a cunei progressivi sono, per gli interventi di salute della popolazione, lo strumento raccomandato dalla letteratura metodologica, e la loro pianificazione prospettica ne accresce la validità interna; la validità esterna va valutata a parte. ↑
351. Trasformazione delle stime in prove: confrontando l'andamento, ad esempio, degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche — particolarmente elevati in Liguria — nelle sedi attivate per prime e a copertura più intensa con quello delle sedi attivate più tardi, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata sui dati liguri, via via che la sperimentazione li produrrà. ↑
352. Verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (VIR; DPCM 169/2017): è valutazione ex post, di norma dopo un biennio, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, che chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva. ↑
353. Clausola valutativa: sul piano regionale, impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti; in Liguria, dove il servizio è già istituito dalla legge regionale 20 del 2023 e dove la legge stessa prevede un Osservatorio, tale clausola si innesta su una base legislativa già esistente e lega la misurazione tecnica alla responsabilità politica e alla trasparenza verso il legislatore regionale. ↑
354. Manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi (2008): articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione delle variabili alla normalizzazione, alla ponderazione e all'analisi di robustezza. ↑
355. Benessere Equo e Sostenibile (BES), ISTAT: dodici domini con indici compositi; con la legge n. 163/2016 di riforma del bilancio, una selezione di indicatori è entrata nel ciclo della programmazione economica, a precedente istituzionale dell'impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica. ↑
356. Regole di coerenza e di non duplicazione: il divieto di doppia contabilizzazione impone che, nel medesimo calcolo, una grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali già adottata nella Parte E. ↑
357. Risparmi diretti complessivi per il Servizio sanitario regionale stimati nell'ordine di 6 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 10 nello scenario base e 14 nello scenario espansivo, collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa dell'intervallo e con il canale della mobilità in posizione marginale. ↑
358. Saldo diretto per il bilancio sanitario, dato dalla differenza tra risparmi diretti e costo del servizio, dell'ordine di -3, -4 e -4 milioni di euro annui nei tre scenari: è lievemente negativo, poiché il canale della mobilità, pur in una regione debitrice, non concorre al pareggio diretto, essendo la fuga di natura chirurgica e non psicologica. ↑

359. Il saldo diretto negativo è dichiarato senza attenuazioni e non costituisce una debolezza dell'analisi, ma il suo profilo onesto: a differenza della Puglia, dove il recupero della mobilità passiva concorre al pareggio diretto perché la fuga riguarda anche prestazioni che un servizio territoriale può trattenere, in Liguria la fuga è chirurgica e il valore dell'intervento risiede in misura preponderante nelle ricadute economico-sociali; tuttavia, in un contesto di pressione finanziaria e di primato nazionale della domanda di salute mentale, il contenimento della domanda impropria conserva una salienza diretta non trascurabile. ↑
360. Ritorno sociale: le ricadute economico-sociali comprendono il valore della maggiore produttività recuperata, la riduzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, le efficienze nel sistema dei servizi di salute mentale e il sollievo alle figure di cura familiari. Nella regione più anziana d'Italia, a fortissima presenza di cronicità, le componenti della produttività recuperata e del sollievo ai familiari hanno un peso particolarmente elevato. ↑
361. Ricadute economico-sociali stimate nell'ordine di 29 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 55 nello scenario base e 85 nello scenario espansivo, secondo i metodi del ritorno sociale sull'investimento, con criteri di stima conservativi. ↑
362. Ritorno complessivo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali, dell'ordine di 35, 65 e 99 milioni di euro annui nei tre scenari; il saldo complessivo, al netto del costo del servizio, è dell'ordine di +26, +51 e +81 milioni di euro annui. ↑
363. Rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,9:1 nello scenario conservativo, 4,6:1 nello scenario base e 5,5:1 nello scenario espansivo, in linea con il valore validato sulle altre regioni e coerente con le stime metodologicamente fondate della letteratura. ↑
364. Caso economico e caso finanziario secondo il Five Case Model: il caso finanziario, riferito al solo bilancio sanitario, presenta un saldo diretto lievemente negativo; il caso economico, riferito alla collettività, è ampiamente positivo. La distinzione tra le due grandezze è la chiave dell'analisi. ↑
365. Sostenibilità finanziaria: il costo del servizio si colloca nell'ordine dello 0,3-0,5% di un Fondo Sanitario Regionale dell'ordine di 3,5 miliardi di euro; benché la regione operi sotto pressione finanziaria e con un disavanzo strutturale coperto con risorse regionali, l'importo è contenuto, tanto più che una quota è già a bilancio per la sperimentazione avviata, e l'investimento incrementale è quello necessario a colmare il divario verso il fabbisogno. ↑
366. Lacuna prioritaria: le grandezze economiche qui impiegate sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione (2,6%) e non estratte dai conti regionali certificati delle cinque Aziende Sociosanitarie Liguri e degli IRCCS; la loro verifica è condizione per la presentazione alle autorità di finanza pubblica, e in Liguria, a differenza della Toscana, è ancora poco mitigata da dati operativi, poiché la sperimentazione è appena avviata. ↑
367. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 300.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato dall'offerta strutturata attuale; la sperimentazione, appena avviata e dimensionata a trentotto psicologi, ne intercetterà in prima applicazione una quota minima, destinata a crescere con la conduzione a regime. ↑
368. Modello organizzativo: lo psicologo di base opera nelle Case della Comunità, prioritariamente di tipo Hub, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 del 2023; nel modello ligure la sperimentazione è in fase di avvio nelle cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, con almeno due psicologi territoriali per distretto e l'inserimento, ove esistente, nell'unità operativa di psicologia clinica. A differenza del Veneto, la Liguria non dispone di un'azienda regionale unica, ma l'Azienda Ligure Sanitaria svolge funzioni regionali di coordinamento, programmazione e governo, sicché l'omogeneità attuativa e le economie di scala sono assicurate a livello regionale, affiancate dall'Osservatorio previsto dalla legge. ↑

369. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
370. Percorso clinico: accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, secondo quanto già previsto per la sperimentazione; valutazione iniziale e progetto clinico individuale; ciclo di colloqui brevi e programma di sostegno personalizzato; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. ↑
371. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
372. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
373. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
374. ↑
375. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). Questa parte conclusiva applica la griglia di giudizio del telaio, i criteri dell'OCSE-DAC, che attraversano l'intero studio come metro di valutazione e convergono qui nella sintesi; fornisce inoltre il contenuto del caso strategico del Five Case Model. ↑
376. Criteri di valutazione dell'OCSE-DAC (rivisti nel 2019, «Better Criteria for Better Evaluation»): sei lenti complementari — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità — che insieme danno un quadro complessivo dell'intervento. ↑
377. Rilevanza: l'intervento risponde a un bisogno reale e di grande dimensione — dell'ordine di 300.000 persone con disagio comune in larga parte inevaso, in una regione che registra la più alta prevalenza nazionale di utenti dei servizi di salute mentale — e all'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza. ↑
378. Coerenza: l'intervento è compatibile e complementare con gli standard dell'assistenza territoriale (DM 77/2022), con la Missione 6 del PNRR e con la legge regionale che già ne ha istituito la funzione — l'articolo 76 della legge 20 del 2023 — ed è costituzionalmente difendibile entro i confini tracciati dal giudice delle leggi, operando mediante un rapporto convenzionale; la Liguria, sotto pressione finanziaria e con un disavanzo strutturale coperto con risorse regionali, non è sottoposta a piano di rientro ma è debitrice nella mobilità. ↑
379. Efficacia: l'evidenza internazionale documenta che i modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie raggiungono gli obiettivi clinici, con tassi di recupero dell'ordine del 50% nel programma inglese; a differenza della Toscana, la Liguria non dispone ancora di dati di esito propri, sicché il giudizio di efficacia poggia, allo stato, sui benchmark internazionali e sul disegno valutativo prospettico, che la sperimentazione appena avviata è chiamata a corroborare. ↑
380. Efficienza: l'intervento è favorevole in termini di costo-utilità — con dominanza per paziente e costo-efficacia confermata dall'analisi probabilistica — a fronte, per la Liguria, di un saldo diretto lievemente negativo sul solo bilancio sanitario, di entità modesta rispetto a un finanziamento dell'ordine di 3,5 miliardi;

l'efficienza allocativa è dunque elevata, la convenienza per il solo bilancio lievemente negativa, in quanto il canale della mobilità, pur in una regione debitrice, è marginale perché la fuga è chirurgica. ↑

381. Impatto: l'impatto distributivo è favorevole, poiché i benefici si concentrano dove l'accesso è più difficile — l'entroterra appenninico, l'età anziana, l'utenza straniera e le popolazioni gravate dalle liste di attesa — riducendo il gradiente territoriale; il ritorno complessivo è dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. ↑
382. Sostenibilità: l'intervento è finanziariamente sostenibile — a fronte di un costo modesto, di una pluralità di coperture e di una quota già a bilancio per la sperimentazione avviata — e organizzativamente, in quanto innestato sulla rete territoriale delle Case della Comunità; poiché la legge è già vigente ma la sperimentazione è appena avviata, la leva decisiva della sua durata non è l'istituzionalizzazione per legge né la maturità operativa, ma la conduzione a regime con un rapporto convenzionale stabile, che sottrarrebbe il servizio alla fragilità della fase di avvio. ↑
383. Analisi multi-criterio (buone pratiche ISPOR): rende esplicito il bilanciamento dei criteri non riducibili a denaro — l'equità, la fattibilità, la coerenza strategica, la robustezza dell'evidenza — attribuendo a ciascuno un peso e a ciascuna opzione un punteggio. ↑
384. Risultato dell'analisi multi-criterio: su otto criteri pesati, l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 80,80 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri tranne la fattibilità immediata; rispetto alla Toscana, il sub-punteggio di fattibilità resta elevato, poiché la Liguria dispone già di una legge regionale dedicata e di una sperimentazione avviata, mentre il sub-punteggio di robustezza dell'evidenza propria è più contenuto, non disponendo la regione di dati di esito già maturi; il risultato è stabile rispetto ai pesi adottati. ↑
385. Le tre affermazioni del cruscotto decisionale per la Liguria: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, trascurabile rispetto a un finanziamento dell'ordine di 3,5 miliardi, pur con una salienza diretta non nulla nel contesto delle liste di attesa e della più alta domanda nazionale di salute mentale; il ritorno per la collettività è ampio (rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno); il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali. ↑
386. Raccomandazione centrale: la decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già istituita dall'articolo 76 della legge 20 del 2023 e avviata in via sperimentale — né se dotarla di una legge, già esistente, ma se condurla dall'avvio della sperimentazione alla strutturazione a regime, stabilizzando il rapporto convenzionale previsto dalla legge, e dimensionarla, portandola dalla copertura attuale, dell'ordine del tre-quattro per cento del fabbisogno, alla copertura sistematica, dell'ordine di 250 incarichi nello scenario di base e di 330 in quello espansivo. ↑
387. Cruscotto secondo il Quintuple Aim: la sintesi del valore è letta lungo le cinque dimensioni dell'esito di salute, dell'esperienza, del costo, del benessere degli operatori e dell'equità. ↑
388. Limite principale (radicamento nei dati): le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione ligure (2,6%), e non estratte dai conti regionali certificati delle cinque Aziende e degli IRCCS; tale sostituzione è la condizione per la presentazione agli organi di controllo, ed è in Liguria, a differenza della Toscana, ancora poco mitigata da dati operativi, poiché la sperimentazione è appena avviata. ↑
389. Cautele di trasferibilità e di fonte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la cifra del ritorno è prudenziale e non ponderata per l'equità. ↑
390. Agenda di ricerca: l'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso le cinque Aziende e gli IRCCS, seguito dalla strutturazione della rilevazione di servizio fin dall'avvio e dalla valutazione controfattuale fondata su un disegno a cunei progressivi pianificato prospetticamente tra le

Aziende e i loro distretti. ↑

391. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale. Poiché la sperimentazione è appena avviata, la Liguria può progettare il flusso informativo fin dal primo giorno, in modo completo e uniforme, senza dover recuperare a posteriori dati frammentari; l'Osservatorio previsto dalla legge ne è la sede di governo. ↑
392. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑
393. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
394. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
395. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: in Liguria sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nell'entroterra appenninico, anziano, disperso e in spopolamento, dove la conformazione vallata e montana rende difficoltoso il raggiungimento dei servizi; tali strumenti sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza. ↑
396. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
397. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso l'Università di Genova); post-universitario specialistico (corso semestrale regionale abilitante, già previsto dalla legge regionale con attestato rilasciato dalla Regione, sulla psicologia di base e le cure primarie, comprensivo della competenza per l'età anziana, per l'entroterra e della competenza culturale per l'utenza straniera); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). ↑
398. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. L'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. ↑
399. ↑
400. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. L'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. Questa parte sviluppa i metodi di modellazione e di gestione dell'incertezza del quinto dominio, secondo le buone pratiche di ricerca sulla modellazione dell'ISPOR e dell'Accademia delle scienze, ed è riportata secondo lo standard CHEERS 2022. ↑
401. Modello di Markov a coorte, strumento standard della valutazione economica in sanità: rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi (sintomatico, recupero, cronico, morte), scanditi da cicli con correzione di metà ciclo; la microsimulazione ne costituisce la variante per le traiettorie individuali. ↑
402. Risultati del caso base (singolo paziente, orizzonte di cinque anni, valori scontati): il braccio dell'intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un'utilità di 3,627 anni di vita ponderati, contro un costo di circa 3.799 euro e un'utilità di 3,392 dell'assistenza usuale; l'intervento è quindi meno costoso (di circa 1.304 euro) e più efficace (di circa 0,236 anni), configurando una dominanza. ↑

403. La dominanza si spiega con la struttura del modello: a fronte di un costo iniziale contenuto, l'intervento accresce il tempo trascorso nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce il tempo trascorso nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte. Il risultato per paziente è il fondamento microeconomico delle stime aggregate della Parte E ed è indipendente dalla regione. ↑
404. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. ↑
405. ↑
406. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudenziale per l'ottimismo delle stime. ↑
407. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
408. Quadro economico consolidato per la Liguria (Parte E): a regime, da circa 170 a circa 330 psicologi, costo del servizio di 9-18 milioni, risparmi diretti di 6-14 milioni, ricadute sociali di 29-85 milioni; il saldo diretto è lievemente negativo, il saldo complessivo positivo, con rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno. ↑
409. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
410. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio; in Liguria possono essere definiti fin dall'avvio della sperimentazione. ↑
411. Valori regionali di ancoraggio per la Liguria: popolazione di 1.510.143 abitanti (Censimento ISTAT 2024), in lievissimo aumento solo per saldo migratorio e con la struttura per età più anziana d'Italia; finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 3,5 miliardi di euro, sotto pressione finanziaria e con un disavanzo strutturale coperto con risorse regionali ma senza piano di rientro in atto; saldo di mobilità passivo (regione debitrice), con fuga concentrata nelle specialità chirurgiche; fabbisogno a regime fino a circa 330 psicologi nello scenario espansivo. ↑
412. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione ligure (2,6%), e non estratti dai conti regionali certificati; i dati da acquisire presso le cinque Aziende Sociosanitarie Liguri e gli IRCCS sono elencati nella tabella seguente, e in Liguria, a differenza della Toscana, la loro mancanza è ancora poco mitigata da dati operativi, poiché la sperimentazione è appena avviata. ↑
413. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑
414. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni agli studi pugliese, lombardo, veneto, emiliano-romagnolo, piemontese e toscano, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑

415. Analisi di sensibilità a una via: ciascun parametro è fatto variare del 25% in più e in meno, misurandone l'effetto sul beneficio monetario netto; il diagramma a tornado ordina i parametri per influenza, con l'efficacia clinica, i tassi di ricaduta e di cronicizzazione e il costo dello stato cronico tra i più influenti. ↑
416. Incertezza strutturale: oltre all'incertezza dei parametri, l'incertezza sulla struttura e sulle assunzioni del modello è trattata mediante analisi di scenario, e i risultati sono riportati secondo lo standard CHEERS, con validazione della coerenza interna ed esterna. ↑
417. Analisi di sensibilità probabilistica: il modello è eseguito diecimila volte con estrazione casuale dei parametri dalle rispettive distribuzioni (simulazione Monte Carlo), propagando l'incertezza dei parametri sull'incertezza del risultato. ↑
418. Soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, valore di riferimento nella prassi italiana e internazionale. ↑
419. Curva di accettabilità della costo-efficacia: alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è dell'88,9% e la probabilità che sia dominante dell'84,6%; il beneficio monetario netto medio sulle diecimila iterazioni è di circa 7.815 euro per paziente, con intervallo di credibilità al 95% da circa -5.736 a circa +21.501 euro. ↑
420. Distinzione tra costo-utilità e impatto sul bilancio per la Liguria: la probabilità di costo-efficacia è un risultato di efficienza, riferito al singolo paziente, che valorizza il guadagno di salute e l'intera traiettoria di costo del modello; esso è coerente con il saldo diretto aggregato della Parte E, che per la Liguria è lievemente negativo, poiché la traduzione dal modello per paziente all'aggregato regionale incorpora le correzioni per peso morto e per l'effettiva monetizzabilità nel bilancio dei costi evitati, e poiché il canale della mobilità, pur in una regione debitrice, è solo marginalmente pertinente, essendo la fuga di natura chirurgica. L'efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è lievemente negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali. ↑
421. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. ↑
422. ↑
423. Legge regionale della Lombardia n. 22 del 14 dicembre 2021, di riforma del sistema sociosanitario: riorganizza la medicina territoriale istituendo circa cento distretti in luogo dei ventisette preesistenti, oltre duecento Case della Comunità, una sessantina di Ospedali di Comunità e circa cento Centrali Operative Territoriali; le Case della Comunità sono concepite come sedi di équipe multidisciplinari che comprendono esplicitamente gli psicologi, e le Centrali Operative Territoriali sono destinate a sperimentare strumenti di intelligenza artificiale. La funzione psicologica nelle cure primarie è dunque già prevista, in forma generica, dalla riforma stessa. ↑
424. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. ↑
425. Priorità di acquisizione: i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso, essendo il canale della mobilità non applicabile in Lombardia — sono quelli su cui il valore dell'informazione è più elevato e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati. ↑
426. Verifica empirica: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Agenzie di Tutela della Salute (stepped-wedge), oggetto della Parte L, riduce l'incertezza dei parametri sostituendo le stime con misure osservate sui dati lombardi. ↑

427. Commissione europea, rapporto sulla salute mentale 2024: quasi un giovane europeo su due non ha ricevuto un supporto adeguato e solo la metà delle persone con ansia o depressione chiede aiuto; il divario tra prevalenza reale e accesso ai servizi deriva da barriere strutturali, economiche, culturali e di stigma. È il divario che un servizio di primo livello, accessibile e privo di stigma, ha la funzione di colmare. ↑
428. Carenza di offerta psicologica: secondo dati del Ministero della Salute riferiti al 2017 l'Italia dispone di 8,5 psicologi ogni 100.000 abitanti nel Servizio sanitario complessivo, e di meno di 3 ogni 100.000 nelle sole strutture pubbliche di salute mentale, tra le dotazioni più basse d'Europa; il sistema olandese che integra psicologi nelle cure primarie (POH-GGZ) costituisce il riferimento internazionale del modello. ↑
429. Sistema Informativo per la Salute Mentale (Rapporto SISM): l'utenza in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale della Lombardia è stimabile, per quota di popolazione, nell'ordine di 150.000 persone; la grandezza è da confermare sui dati regionali, dei quali la specifica di estrazione chiede la disaggregazione per Agenzia di Tutela della Salute. ↑
430. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche in Lombardia: stimabili, per quota di popolazione e tendenza nazionale, nell'ordine di 45.000-50.000 l'anno, in crescita rispetto al periodo pre-pandemico e con trend accentuato tra minori e giovani adulti; le sindromi nevrotiche e somatoformi ne costituiscono la causa più frequente, quadri comuni che non richiederebbero il contesto dell'emergenza. ↑
431. Stato attuale e fabbisogno: a differenza della Puglia, la funzione psicologica territoriale è prevista dalla riforma del 2021 ma non è strutturata né dimensionata; il fabbisogno a regime, applicando i rapporti organizzativi del modello (circa un psicologo ogni 4.400-4.900 abitanti), è dell'ordine di 2.190 incarichi, il più elevato d'Italia, con scenari di copertura nell'ordine di 1.100, 1.700 e 2.190. ↑
432. L'algoritmo di distribuzione territoriale degli incarichi pondera i distretti per indice di vecchiaia, indice di deprivazione socioeconomica e prevalenza di cronicità e multimorbidità, attribuendo pesi maggiori alle aree alpine interne e alle periferie urbane più fragili, a presidio dell'equità territoriale. ↑
433. Contesto di bilancio: la Lombardia dispone del più ampio finanziamento sanitario regionale del Paese, dell'ordine di 21 miliardi di euro, e presenta conti in sostanziale equilibrio; a differenza della Puglia, non è sottoposta a piano di rientro. Il vincolo generale di destinazione delle risorse ai livelli essenziali permane, e con esso l'esigenza di dimostrare efficienza e ritorno di ogni nuova linea di spesa. ↑
434. Mobilità sanitaria attiva (Ministero della Salute e Agenas): la Lombardia presenta il più elevato saldo di mobilità attiva d'Italia, dell'ordine di 580 milioni di euro, a fronte di oltre un miliardo di prestazioni erogate a non residenti; è il primo polo attrattivo del Paese. Ne consegue che il canale del recupero della mobilità passiva, centrale per le regioni meridionali, non si applica: la Lombardia è regione creditrice. ↑
435. Pronto soccorso: gli accessi annui in Lombardia sono dell'ordine di 3.000.000-3.200.000, con una quota inappropriata rilevante ancorché inferiore a quella delle regioni con rete territoriale più debole; il vero margine di inefficienza lombardo, sul quale il servizio agisce, risiede nelle liste di attesa e nel ritardo della rete territoriale, più che nella mobilità. ↑
436. Farmaceutica: la Lombardia presenta un consumo complessivo dell'ordine di 900-950 dosi giornaliere ogni mille abitanti, inferiore a quello delle regioni meridionali e prossimo alla media nazionale; l'intercettazione del disagio psichico nelle cure primarie resta migliorabile, con margini di appropriatezza nella sostituzione di terapie croniche non necessarie con percorsi psicologici. ↑
437. Liste di attesa e rete territoriale: il modello lombardo, fondato sull'eccellenza ospedaliera e specialistica, ha storicamente dedicato minore attenzione alla rete di prossimità, la cui fragilità è emersa con la pandemia; le liste di attesa ne sono la testimonianza. Il Servizio di Psicologia di Base completa la rete territoriale in costruzione e ne accresce la capacità di intercettare il bisogno in prossimità. ↑

438. Cornice normativa: a livello regionale la legge n. 22 del 2021, di riforma del sistema sociosanitario, che pone al centro la medicina territoriale e prevede esplicitamente gli psicologi nelle Case della Comunità e l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle Centrali Operative Territoriali; a livello nazionale il decreto ministeriale 77 del 2022 sull'assistenza territoriale, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'accordo della specialistica ambulatoriale per i psicologi convenzionati; a livello europeo il regolamento 2021/2282 sull'HTA e il regolamento sull'intelligenza artificiale. ↑
439. Popolazione residente in Lombardia 10.033.918 (Censimento permanente ISTAT 2024), pari al 17,0% della popolazione nazionale, la più popolosa d'Italia; componente straniera 12,2%; aspettativa di vita dell'ordine di 84 anni; dodici province, con la Città Metropolitana di Milano che supera da sola 1,36 milioni di residenti. Il Servizio sanitario regionale è articolato in otto Agenzie di Tutela della Salute, con funzioni di programmazione e governo, e in ventisette Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, che integrano polo ospedaliero e polo territoriale ed erogano le prestazioni insieme a un'ampia rete di soggetti privati accreditati e di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, presenti nella più alta concentrazione nazionale. ↑
440. ↑
441. Popolazione residente in Lombardia 10.033.918 (Censimento permanente ISTAT 2024), pari al 17,0% della popolazione nazionale, la più popolosa d'Italia; componente straniera 12,2%; aspettativa di vita dell'ordine di 84 anni; dodici province, con la Città Metropolitana di Milano che supera da sola 1,36 milioni di residenti. Il Servizio sanitario regionale è articolato in otto Agenzie di Tutela della Salute, con funzioni di programmazione e governo, e in ventisette Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, che integrano polo ospedaliero e polo territoriale ed erogano le prestazioni insieme a un'ampia rete di soggetti privati accreditati e di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, presenti nella più alta concentrazione nazionale. Questa parte copre l'ottavo dominio del modello HTA, il profilo del paziente e sociale, e risponde al criterio di impatto della griglia di giudizio; l'equità è trattata come dimensione costitutiva della valutazione, secondo l'evoluzione che ha affiancato l'equità in salute agli obiettivi di esito, esperienza e costo. ↑
442. Gradiente sociale della salute mentale: le popolazioni in deprivazione presentano prevalenze sistematicamente più elevate di disturbi mentali comuni e un accesso più difficile ai servizi. In Lombardia il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato (dell'ordine del 18%), sicché il gradiente sociale opera soprattutto entro alcune aree — le zone alpine interne e talune periferie urbane — anziché come tratto diffuso; la dimensione territoriale dell'equità prevale, in Lombardia, su quella socio-economica. ↑
443. La gratuità, la prossimità e l'assenza di stigma del servizio di primo livello abbattano le barriere economiche, geografiche e culturali che gravano in misura maggiore sulle popolazioni svantaggiate; in Lombardia rileva in particolare l'abbattimento della barriera geografica nelle aree alpine, dove la distanza dai servizi è il principale ostacolo all'accesso. ↑
444. Variabili di equità, accesso e protezione finanziaria seguite dallo studio: riduzione dei tempi di attesa per l'accesso psicologico — in Lombardia la principale dimensione dell'equità nell'accesso — accessibilità geografica nelle aree alpine e interne, gradiente socio-economico nell'accesso, equità di esito tra gruppi, equità di genere, accesso per le popolazioni straniere e fragili e per le persone con disabilità, gratuità per i gruppi vulnerabili, copertura del bisogno non soddisfatto. ↑
445. Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA), secondo Cookson, Asaria e colleghi: estende la valutazione economica alla dimensione dell'equità, stimando come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l'effetto sulle disuguaglianze, mediante anni di vita ponderati per l'equità, indice di concentrazione e indici di disuguaglianza assoluta e relativa. ↑

446. Direzione del risultato distributivo: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove l'accesso è oggi più difficile — le aree alpine e le popolazioni gravate dalle liste di attesa — i benefici dell'intervento si concentrano sui gruppi più svantaggiati nell'accesso, riducendo il gradiente territoriale negli esiti di salute mentale; l'intervento migliora l'esito medio e ne comprime al tempo stesso la disuguaglianza. ↑
447. Ponderazione distributiva: l'attribuzione di pesi maggiori ai benefici che ricadono sui più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, come riferimento conservativo, il rapporto beneficio-costi non ponderato già esposto nella Parte E, dell'ordine di 3,8-5,4 a uno. In Lombardia, ove la popolazione non è prevalentemente deprivata, l'effetto della ponderazione sarebbe più contenuto che nel Mezzogiorno, il che rende la scelta non ponderata tanto più prudente. ↑
448. Algoritmo allocativo quale meccanismo operativo dell'equità: la distribuzione territoriale degli incarichi non segue la sola popolazione, ma pondera ciascun distretto per l'indice di vecchiaia, l'indice di deprivazione socioeconomica e la prevalenza di cronicità e multimorbidità, attribuendo pesi maggiori alle aree alpine interne e alle periferie urbane più fragili. ↑
449. Indice di deprivazione multipla: misura sintetica costruita su reddito, occupazione, istruzione, salute, condizione abitativa e ambiente, impiegata per individuare le aree prioritarie nell'allocazione degli incarichi. ↑
450. Divari territoriali in Lombardia: il divario rilevante non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra l'area metropolitana densa e ben servita e le aree alpine di Sondrio e delle valli prealpine, a popolazione anziana e dispersa, cui si aggiungono talune periferie urbane; è in queste aree che la sola presenza fisica di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio. ↑
451. Liste di attesa e rete territoriale quale dimensione di equità: in Lombardia, dove il canale della mobilità recuperata non si applica (la regione è creditrice), la principale leva distributiva è la riduzione delle liste di attesa e il completamento della rete territoriale, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato; sul piano nazionale, il rafforzamento della rete lombarda concorre inoltre ad attenuare la pressione che alimenta la mobilità dal Mezzogiorno. ↑
452. Protezione finanziaria: il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata diretta per la psicoterapia, l'impoverimento connesso alle cure e le spese sanitarie catastrofiche, con beneficio maggiore per i redditi bassi, per i quali la psicoterapia privata — di costo non trascurabile anche in Lombardia — è spesso inaccessibile. ↑
453. Copertura del bisogno non soddisfatto come equità: intercettare la quota inevasa del disagio — dell'ordine di due milioni di persone, metà delle quali non chiede aiuto — significa raggiungere proprio coloro che hanno minore probabilità di accedere spontaneamente ai servizi. ↑
454. Collegamento al monitoraggio: gli indicatori di equità — accesso per area e per livello socio-economico, gradiente dell'esito, tempi di attesa per area — fanno parte del sistema di indicatori della Parte L, e consentono di accertare nel tempo se il servizio raggiunga le comunità più distanti e i gruppi più fragili. ↑
455. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici come misure; servizio attuale come comparatore. Il caso di riferimento è il medesimo adottato per la Puglia e per le altre Regioni, a garanzia di comparabilità. ↑
456. ↑

457. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, in linea con la guida della Commissione europea e con la prassi della valutazione economica in sanità, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici come misure; servizio attuale come comparatore. Il caso di riferimento è il medesimo adottato per la Puglia e per le altre Regioni, a garanzia di comparabilità. Standard di reporting e di conduzione: la lista PRISMA 2020 per la revisione sistematica (strategia di ricerca, selezione, estrazione e sintesi) e la lista STROBE per gli studi osservazionali sui dati reali. ↑
458. Questa parte copre il quarto dominio del modello HTA, l'efficacia clinica, che insieme ai primi tre costituisce il nucleo della valutazione rapida di efficacia relativa; la sintesi dell'evidenza segue lo standard PRISMA e ne gradua la certezza con il sistema GRADE. ↑
459. Collaborative Care Model: paradigma di integrazione della salute mentale nelle cure primarie validato da oltre novanta studi randomizzati controllati; uno studio fondativo (JAMA, 2002) documentò che circa la metà dei pazienti otteneva una riduzione dei sintomi pari almeno alla metà a dodici mesi, contro meno di un quinto nella cura usuale. ↑
460. Woltmann e colleghi (American Journal of Psychiatry, 2012): meta-analisi su cinquantasette studi controllati, con un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard. ↑
461. Revisione sistematica (BMC Primary Care, 2024) su quarantadue implementazioni del Collaborative Care Model in Europa, Nord America e Australia: riduzione media dei sintomi depressivi del 47% a sei mesi, dei sintomi ansiosi del 43%, miglioramento del funzionamento del 38%, riduzione del 34% degli accessi al pronto soccorso per sintomi psicosomatici e del 41% dei ricoveri psichiatrici. ↑
462. Strumenti di esito validati e impiegati in tutti i programmi: il PHQ-9 per i sintomi depressivi (sensibilità 88%, specificità 85%) e il GAD-7 per i sintomi d'ansia (sensibilità 89%, specificità 82%). ↑
463. Meta-analisi sulle cure integrate nelle cure primarie: miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante dei sintomi depressivi, con coefficiente beta standardizzato di $-0,11$; su scala di popolazione anche un piccolo spostamento medio dei punteggi riduce sensibilmente la proporzione di persone che superano le soglie cliniche. ↑
464. Sistema GRADE per la graduazione della certezza dell'evidenza, fondato sulla valutazione del rischio di bias, dell'incoerenza, dell'indirettezza, dell'imprecisione e del bias di pubblicazione; per l'efficacia dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni la certezza è nel complesso da moderata ad alta. ↑
465. Programma inglese di terapie psicologiche (NHS Talking Therapies, già IAPT; dati NHS England Digital, settembre 2024): oltre 1,3 milioni di persone trattate nell'anno 2023-2024, con tasso di recupero dell'ordine del 50% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su un bacino di oltre cinquantasei milioni di abitanti. ↑
466. Programma inglese, dati 2022-2023 (NHS Digital): 1,76 milioni di persone inviate, 1,22 milioni entrate in trattamento e 672.000 cicli completati, con un tasso di recupero del 49,9%, prossimo all'obiettivo del 50%, e un miglioramento affidabile del 67,8%. ↑
467. ↑
468. Programma inglese, dati 2022-2023 (NHS Digital): 1,76 milioni di persone inviate, 1,22 milioni entrate in trattamento e 672.000 cicli completati, con un tasso di recupero del 49,9%, prossimo all'obiettivo del 50%, e un miglioramento affidabile del 67,8%. Questa parte copre tre domini del modello HTA — il profilo etico (dominio 6), il profilo organizzativo (dominio 7) e il profilo giuridico (dominio 9) — che completano la valutazione oltre i piani già trattati. ↑

469. Profilo etico: le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato; la persona resta il soggetto, e mai l'oggetto, della presa in carico. ↑
470. Consenso informato: è modulare, prestato distintamente per i diversi trattamenti, e reso anche in forma digitale; nella salute mentale i dati sono ultrasensibili, sicché la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi possa accedervi. ↑
471. Conduzione etica della valutazione: gli esiti sono resi pubblici indipendentemente dal loro segno, a garanzia contro la distorsione da selezione dei risultati favorevoli, e l'intero impianto è sottoposto all'approvazione del comitato etico territorialmente competente. ↑
472. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante, senza che ne siano registrate le modalità. ↑
473. Articolo 32 della Costituzione e legge 23 dicembre 1978, n. 833: la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, e il Servizio sanitario nazionale fondato su universalità, eguaglianza ed equità. ↑
474. Articolo 117, terzo comma, della Costituzione: la tutela della salute è materia di competenza concorrente, nella quale allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio e l'organizzazione del servizio; la legge regionale lombarda n. 22 del 2021 opera legittimamente entro tale competenza, sul piano organizzativo. ↑
475. Articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è la leva attraverso cui un'eventuale legge statale potrebbe ricondurre la psicologia di base tra le prestazioni garantite in modo uniforme su tutto il territorio. ↑
476. Corte costituzionale, sentenza 13 dicembre 2021, n. 241: ha riconosciuto legittimo il modello regionale del servizio di psicologia di base, in quanto organizzazione del servizio sanitario che si avvale di professionisti già esistenti; è un precedente di rilievo diretto per la Lombardia, che intende strutturare entro la propria competenza organizzativa la funzione già prevista. ↑
477. Base giuridica regionale: la legge regionale n. 22 del 2021 ha riformato il sistema sociosanitario lombardo prevedendo gli psicologi nelle Case della Comunità e l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle Centrali Operative Territoriali; la decisione non verte sul prevedere la funzione, già prevista, ma sullo strutturarla e dimensionarla. ↑
478. Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2026: le Regioni in piano di rientro non possono utilizzare i fondi del proprio Servizio sanitario per finalità diverse dalla garanzia dei livelli essenziali. La Lombardia, con conti in equilibrio e non sottoposta a piano di rientro, non è soggetta a tale vincolo; permane il principio generale di destinazione delle risorse ai livelli essenziali, che la riforma rispetta. ↑
479. Deontologia professionale: il servizio opera nel rispetto delle norme deontologiche della professione, sotto la vigilanza dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che concorre alla governance e alla formazione. ↑
480. Responsabilità clinica e ruolo dell'IA: l'impiego dell'intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali — il medico di medicina generale resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell'intervento psicologico, e l'IA è assimilata a un dispositivo di supporto, non a una figura che compie atti — sicché non si introduce una nuova figura professionale, ma uno strumento che assiste quelle esistenti. ↑
481. Conformità degli strumenti di IA: il regolamento europeo sull'IA classifica come ad alto rischio i sistemi impiegati nei dispositivi medici; il regolamento sui dispositivi medici impone la marcatura CE; il regolamento sulla protezione dei dati ne disciplina il trattamento; vi si innestano la supervisione umana

costante, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias, la trasparenza e il divieto di discriminazione algoritmica. ↑

482. Equità digitale: per non generare nuove disuguaglianze, sono previsti canali tradizionali paralleli per chi non dispone di strumenti digitali — segnatamente le persone anziane delle aree alpine — e il supporto multilingue per le popolazioni straniere, ferma restando la garanzia dell’alternativa in presenza. ↑
483. Protezione dei dati: misure di sicurezza robuste — crittografia e pseudonimizzazione per le analisi — consenso modulare anche in forma digitale, collaborazione con l’Autorità garante e acquisizione di software dotati di marcatura adeguata secondo le normali procedure. ↑
484. Iniziativa australiana Better Access (dal 2006): oltre venti milioni di prestazioni a più di tre milioni di persone in dieci anni, con un aumento del tasso di trattamento dei disturbi mentali dal 35% al 46% e un’elevata soddisfazione, sebbene operi per invio esterno e non per integrazione. ↑
485. Trasferibilità e differenze di assetto: i programmi integrati (inglese, olandese e statunitense) collocano il professionista nelle cure primarie, mentre il modello australiano opera per invio esterno; il modello lombardo, che inserisce lo psicologo nelle cure primarie con funzione di filtro, appartiene alla prima famiglia e ne mutua le evidenze con maggiore pertinenza. ↑
486. Esperienze italiane di psicologia nelle cure primarie, tra cui il modello Solano nel Lazio, che hanno anticipato su scala locale l’integrazione del professionista psicologo nelle cure primarie. ↑
487. Cautele di trasferibilità per la Lombardia: i sistemi sanitari differiscono per organizzazione e copertura di partenza; la Lombardia muove da una copertura strutturata sostanzialmente nulla, poiché la funzione è prevista dalla riforma del 2021 ma non dimensionata, e da una domanda più visibile, senza la sotto-rilevazione documentata in alcune regioni meridionali; l’emersione del bisogno può perciò essere più rapida, ma su un volume di gran lunga maggiore, e la disponibilità di organico psicologico formato — a fronte di un fabbisogno dell’ordine di 2.190 incarichi — è il vincolo principale dei primi anni. ↑
488. Verifica locale: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Agenzie di Tutela della Salute (stepped-wedge), oggetto della Parte L, è chiamato a verificare empiricamente sui dati lombardi gli effetti attesi dalla letteratura, trasformando le stime in prove. ↑
489. Confronto economico: i ritorni economici dei programmi internazionali sono trattati, distintamente dagli esiti clinici, nella Parte E, ove il caso lombardo adotta la stima conservativa consolidata e distingue il risparmio diretto per il bilancio dalle ricadute sociali. ↑
490. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica e valore dell’informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica e GRADE, analisi multi-criterio, analisi di impatto della regolamentazione. ↑
491. Valutazione controfattuale d’impatto: i metodi della differenza-nelle-differenze, del controllo sintetico e dei disegni quasi-sperimentali; il dispiegamento scaglionato della riforma (stepped-wedge), nel quale le otto Agenzie di Tutela della Salute passano in sequenza dalla condizione di controllo a quella di intervento, funge da esperimento naturale e ne consente la stima causale (Hussey e Hughes, 2007; Hemming e altri, 2015). ↑
492. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (17,0%) e non estratti dai conti regionali certificati; una specifica di estrazione, da predisporre per le Agenzie di Tutela della Salute e per le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, individua i dati regionali da acquisire — spesa per voce, dimissioni psichiatriche, composizione della mobilità, farmaceutica per categoria, accessi al pronto soccorso per causa, utenza dei Dipartimenti — a sostituzione dei parametri stimati. ↑

493. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali. Per la Lombardia, regione a saldo di mobilità attivo e primo polo attrattivo del Paese, il canale del recupero della mobilità passiva — centrale per le regioni meridionali — non si applica; ne consegue, applicando la stessa metodologia, un saldo diretto negativo, dell'ordine di -25, -35 e -30 milioni di euro per scenario, mentre il ritorno complessivo, dell'ordine di 3,8-5,4 a 1, proviene quasi interamente dalle ricadute sociali, soprattutto dalla produttività recuperata di una popolazione in età lavorativa senza pari. La stima conservativa è adottata come riferimento; le cifre sono ipotesi che lo studio è chiamato a verificare sui dati certificati. ↑
494. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione e Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, Ordine degli Psicologi della Lombardia, università e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico — e da un responsabile scientifico; è sottoposta all'approvazione del comitato etico territorialmente competente; prevede il consenso informato dei partecipanti; e rende pubblici gli esiti indipendentemente dal loro segno, a garanzia di non distorsione. ↑
495. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nel servizio per la sola finalità clinica; al livello di governo regionale sono trasmessi esclusivamente indicatori aggregati e anonimi; il sistema informativo è interoperabile con il Fascicolo Sanitario Elettronico, su infrastruttura regionale sicura, con consenso modulare. ↑
496. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico (copilota) e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione periodica degli algoritmi e monitoraggio dei bias; conformità al regolamento europeo sull'IA e alla disciplina sui dispositivi medici; l'impiego si allinea alla previsione regionale di strumenti di intelligenza artificiale nelle Centrali Operative Territoriali, ed è auspicata l'istituzione di un comitato etico-scientifico per l'IA in sanità, con le Agenzie di Tutela della Salute, le università e gli Istituti di ricovero. La legge nazionale sull'IA agevola la sperimentazione qualificando i relativi trattamenti come di rilevante interesse pubblico. ↑
497. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi totali; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante, senza che lo studio registri o tratti il dettaglio delle modalità — garanzia di sicurezza e di dignità della persona. ↑
498. ↑
499. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi totali; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante, senza che lo studio registri o tratti il dettaglio delle modalità — garanzia di sicurezza e di dignità della persona. Questa parte copre il settimo dominio del modello HTA, il profilo organizzativo, e fornisce il contenuto del caso commerciale e del caso gestionale del Five Case Model, rispondendo al criterio di sostenibilità. ↑
500. Modello RE-AIM: misura la riuscita e la validità esterna dell'attuazione lungo cinque dimensioni — la portata (quota della popolazione bersaglio raggiunta), l'efficacia (esiti conseguiti), l'adozione (adesione di sedi e professionisti), l'implementazione (fedeltà al modello) e il mantenimento (sostenibilità nel tempo). ↑
501. Quadro consolidato per la ricerca sull'implementazione (CFIR): spiega i determinanti dell'attuazione, articolati in cinque domini — le caratteristiche dell'innovazione, il contesto esterno, il contesto interno, gli individui coinvolti e il processo di attuazione — consentendo l'individuazione ex ante di barriere e facilitatori. ↑

502. Determinanti di implementazione seguiti dallo studio: il tasso di copertura, il grado di adozione delle sedi, la fedeltà al modello, i tempi di attivazione, il numero di psicologi reclutati e formati, la qualità della formazione e della supervisione, il grado di integrazione nei flussi di lavoro, l'aderenza ai percorsi e la scalabilità. ↑
503. Disegno del dispiegamento scaglionato in Lombardia: le otto Agenzie di Tutela della Salute passano in sequenza, per fasi semestrali, dalla condizione di controllo a quella di intervento, a partire dalle Agenzie di maggiore dimensione e prontezza organizzativa, sino a coprire l'intera regione; l'ordine è definito dalla Giunta regionale su criteri trasparenti e reso noto preventivamente. ↑
504. Doppia funzione del dispiegamento scaglionato: esso risponde a un'esigenza organizzativa — attivare il servizio in modo graduale, compatibile con i tempi del reclutamento e della formazione — e al tempo stesso costituisce il fondamento della valutazione controfattuale d'impatto, poiché la successione configura un esperimento naturale, oggetto della Parte L. ↑
505. Reclutamento: a fronte di un fabbisogno a regime dell'ordine di 2.190 psicologi, il più elevato d'Italia, il reclutamento avviene tramite l'iscrizione a un elenco istituito presso ciascuna Agenzia e l'instaurazione di un rapporto convenzionale, con requisiti di iscrizione all'albo e di formazione specifica; in prima applicazione possono accedere i professionisti con pregressa esperienza nell'assistenza psicologica nel Servizio sanitario regionale. ↑
506. Cronoprogramma: l'attivazione procede per fasi semestrali attraverso le otto Agenzie; le attività di reclutamento, formazione, allestimento e avvio sono condotte in modo scaglionato, Agenzia per Agenzia, mentre il monitoraggio e la valutazione accompagnano l'intero arco e proseguono oltre il completamento. ↑
507. Soglia di riuscita del dispiegamento: tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% nella fase di attuazione, a fronte del valore di riferimento del programma inglese; il monitoraggio è chiamato a verificarne il raggiungimento sui dati lombardi. ↑
508. Caso commerciale (Five Case Model): la fattibilità dell'assetto contrattuale poggia sul rapporto convenzionale ancorato all'accordo della specialistica ambulatoriale, da cui un costo medio per incarico dell'ordine di 55.000 euro l'anno e gli scenari di spesa di 60, 95 e 120 milioni già esposti nella Parte E; il modello dell'elenco aziendale e del rapporto convenzionale è già adottato da altre Regioni e non richiede la creazione di nuove figure. ↑
509. Caso gestionale (Five Case Model): l'attuazione è governata su due livelli. A livello regionale, un comitato di indirizzo regionale esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, le Agenzie di Tutela della Salute, le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, la medicina generale, la pediatria di libera scelta, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le università; a livello aziendale, ciascuna Agenzia e Azienda è responsabile dell'attuazione nel proprio ambito. ↑
510. Rischi attuativi e misure di mitigazione: i rischi principali — reclutamento insufficiente, debole adesione della medicina generale, interoperabilità incompleta dei sistemi informativi, disomogeneità territoriale e venir meno delle coperture — sono associati a misure dedicate; il dispiegamento graduale è esso stesso la principale forma di mitigazione, poiché consente di osservare, correggere e adattare prima dell'estensione. ↑
511. Caso finanziario e coperture (Five Case Model): le fonti di copertura comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, dell'ordine di 21 miliardi di euro, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'infrastruttura territoriale e digitale, e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali. ↑

512. Vincoli di bilancio: a differenza della Puglia, la Lombardia dispone di un finanziamento dell'ordine di 21 miliardi di euro con conti in equilibrio e non è in piano di rientro; il costo del servizio, anche a massima copertura, ne costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale, agevolmente assorbibile, sicché la sostenibilità finanziaria è in Lombardia più immediata che altrove. ↑
513. Sostenibilità nel tempo (criterio OCSE-DAC): la sostenibilità è assicurata dalla modestia del costo rispetto al bilancio, dal forte ritorno sociale documentato e dall'istituzionalizzazione del servizio nella rete territoriale prevista dalla riforma del 2021. ↑
514. Nota di cautela metodologica: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la verifica empirica sui dati lombardi, prevista dalla Parte L, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate. ↑
515. Profilo demografico: componente straniera pari al 12,2% dei residenti, nettamente superiore alla media nazionale e motore della crescita; aspettativa di vita dell'ordine di 84 anni, tra le più elevate del Paese; la Città Metropolitana di Milano supera da sola 1,36 milioni di residenti, unico comune oltre il milione; l'invecchiamento, comune alle regioni avanzate, convive con province fra le più giovani d'Italia. ↑
516. Marcata eterogeneità territoriale: l'area metropolitana milanese presenta ampia popolazione in età lavorativa, relativamente più giovane, con elevata domanda connessa ai disturbi comuni e ai ritmi di vita urbani; le province di Bergamo e Brescia, fra le più giovani della regione, condividono un tessuto produttivo dinamico; le aree alpine di Sondrio e delle valli prealpine, a popolazione anziana e dispersa, aggiungono cronicità e difficoltà di accesso. ↑
517. Contesto socioeconomico: la Lombardia è il principale motore economico del Paese, con un rischio di povertà o esclusione sociale tra i più contenuti d'Italia, dell'ordine del 18%, nettamente inferiore alla media nazionale; la deprivazione, pur ridotta in aggregato, si concentra in alcune aree alpine interne e in talune periferie urbane. A differenza delle regioni meridionali, dove il disagio è trainato dalla deprivazione, in Lombardia il bisogno è sospinto soprattutto dall'intensità della vita metropolitana, dal lascito pandemico e dall'invecchiamento delle aree montane. ↑
518. Burden di salute mentale in Lombardia: la popolazione con disagio psichico comune o sottosoglia è stimabile nell'ordine di 2.000.000 di persone (dell'ordine del 20-30% della popolazione adulta); l'utenza in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale è stimabile nell'ordine di 150.000 persone. Le grandezze sono ricostruite per quota di popolazione e da verificare sui dati regionali certificati. ↑
519. ↑
520. Burden di salute mentale in Lombardia: la popolazione con disagio psichico comune o sottosoglia è stimabile nell'ordine di 2.000.000 di persone (dell'ordine del 20-30% della popolazione adulta); l'utenza in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale è stimabile nell'ordine di 150.000 persone. Le grandezze sono ricostruite per quota di popolazione e da verificare sui dati regionali certificati. Definizione dell'intervento: l'inserimento stabile dello psicologo nelle cure primarie, accanto al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro; l'accesso avviene su invio del medico ovvero in forma diretta, secondo percorsi definiti, e i quadri gravi o acuti sono riservati ai servizi specialistici. In Lombardia la funzione è collocata negli studi di medicina generale e nelle Case della Comunità previste dalla riforma del 2021. ↑
521. ↑
522. Burden di salute mentale in Lombardia: la popolazione con disagio psichico comune o sottosoglia è stimabile nell'ordine di 2.000.000 di persone (dell'ordine del 20-30% della popolazione adulta); l'utenza in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale è stimabile nell'ordine di 150.000 persone. Le grandezze sono ricostruite per quota di popolazione e da verificare sui dati regionali certificati. Definizione dell'intervento:

l'inserimento stabile dello psicologo nelle cure primarie, accanto al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, come primo livello di ascolto, intercettazione precoce e filtro; l'accesso avviene su invio del medico ovvero in forma diretta, secondo percorsi definiti, e i quadri gravi o acuti sono riservati ai servizi specialistici. In Lombardia la funzione è collocata negli studi di medicina generale e nelle Case della Comunità previste dalla riforma del 2021. Questa parte copre il quinto dominio del modello HTA, i costi e la valutazione economica; è redatta secondo lo standard di reporting CHEERS 2022, fornisce il contenuto del caso economico e del caso finanziario del Five Case Model e risponde al criterio di efficienza. ↑

523. Modello di costo: il costo medio annuo di un incarico convenzionale a tempo pieno è dell'ordine di 55.000 euro (circa 40 euro l'ora di costo-azienda comprensivo degli oneri, per circa 1.250 ore l'anno, più circa 5.000 euro di costi generali), ancorato all'accordo della specialistica ambulatoriale. ↑
524. Categorie di costo: oltre all'organico psicologico, l'investimento comprende la formazione, la supervisione clinica, la governance, i sistemi informativi e le infrastrutture; tali costi non sanitari sono inclusi coerentemente con la doppia prospettiva adottata. ↑
525. Misure di esito: gli anni di vita ponderati per la qualità e gli esiti clinici validati — il tasso di recupero e il miglioramento affidabile misurati con PHQ-9 e GAD-7 — applicati alla popolazione regionale con disagio comune, dell'ordine di due milioni di persone, la più ampia del Paese. ↑
526. Analisi costo-utilità: secondo il manuale del NICE, il rapporto incrementale di costo-efficacia rapporta il costo aggiuntivo al guadagno in anni di vita ponderati per la qualità e lo confronta con una soglia di disponibilità a pagare (riferimento 30.000 euro per QALY). ↑
527. Analisi di impatto sul bilancio (buone pratiche ISPOR): adotta la prospettiva del detentore del budget, il Servizio sanitario regionale, e stima la differenza tra lo scenario con e senza il servizio, anno per anno, su flussi non scontati, individuando il punto di pareggio finanziario. ↑
528. Canale del pronto soccorso: a fronte di accessi dell'ordine di tre milioni l'anno, una quota di origine psichica è riducibile mediante la presa in carico territoriale, per un risparmio diretto dell'ordine di 6-14 milioni di euro secondo lo scenario; la quota inappropriata lombarda è inferiore a quella delle regioni a rete territoriale più debole. ↑
529. ↑
530. Canale del pronto soccorso: a fronte di accessi dell'ordine di tre milioni l'anno, una quota di origine psichica è riducibile mediante la presa in carico territoriale, per un risparmio diretto dell'ordine di 6-14 milioni di euro secondo lo scenario; la quota inappropriata lombarda è inferiore a quella delle regioni a rete territoriale più debole. Questa parte organizza la misurazione dell'intervento nel tempo: serve ex post i criteri della griglia di giudizio, chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione e fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti. ↑
531. Modello di Donabedian per la qualità dell'assistenza: distingue le dimensioni di struttura, processo ed esito, qui integrate dalla dimensione dell'impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società. ↑
532. Batteria di indicatori: circa cinquantotto misure articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti e circa quaranta richiedono la rilevazione diretta del servizio. ↑
533. Set di esiti essenziali: l'iniziativa COMET e gli standard ICHOM individuano, mediante consenso strutturato (metodo Delphi), un nucleo parsimonioso di esiti da misurare, evitando la proliferazione di misure ridondanti. ↑
534. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline: bisogno e domanda (disponibile), accesso ed equità (da rilevare), processo (da rilevare), esito clinico (da rilevare), economici (misto), impatto sociale (misto), organizzativi (da rilevare), variabili di sintesi (da calcolare); i divari tra Agenzie di Tutela della Salute sono tra le misure di equità. ↑

535. Protocollo minimo di rilevazione: attivo dal primo giorno, registra la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni, deliberatamente essenziale per non gravare sull'attività clinica. ↑
536. Strumenti di esito: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9), con punteggio totale da 0 a 27, soglia di rilevanza clinica intorno a 10 e cambiamento affidabile dell'ordine di 6 punti, e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7), impiegati nei soli punteggi complessivi. ↑
537. Modello di misurazione dei programmi inglesi di terapie psicologiche: la raccolta delle misure di esito a ogni seduta, e non solo all'inizio e alla fine, consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non protrarre percorsi inefficaci. ↑
538. Costituzione della baseline su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti — demografici, epidemiologici, di benessere, di mortalità — forniscono la fotografia del prima e vanno registrati subito; la rilevazione di servizio parte con il primo assistito. Ogni mese di ritardo nell'avvio è un mese di dati di base perduti. ↑
539. Calendario della rilevazione: prima dell'avvio, costituzione della baseline con i dati disponibili e predisposizione del registro e dei questionari; all'avvio, inizio della registrazione; in continuo, trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale con cadenza mensile; periodicamente, calcolo delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale. ↑
540. Valutazione controfattuale d'impatto: misura l'effetto causale dell'intervento confrontando gli esiti dei trattati con il controfattuale, ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente; lo strumento che la rende possibile è il disegno scaglionato del dispiegamento, idoneo esperimento naturale. ↑
541. Differenza-nelle-differenze: confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le Agenzie di Tutela della Salute già attivate e quelle non ancora attivate, sotto l'ipotesi di andamento parallelo; vi si affianca il controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata di unità non trattate. ↑
542. Effetti stimati e validità: l'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e l'effetto medio sui soli trattati; i disegni a esperimento naturale sono, per gli interventi di salute della popolazione, lo strumento raccomandato dalla letteratura metodologica; la validità esterna va valutata a parte. ↑
543. Trasformazione delle stime in prove: confrontando l'andamento, ad esempio, degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche nelle Agenzie che hanno attivato il servizio con quello delle Agenzie che lo attiveranno, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata sui dati lombardi. ↑
544. Verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (VIR; DPCM 169/2017): è valutazione ex post, di norma dopo un biennio, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, che chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva. ↑
545. Clausola valutativa: sul piano regionale, impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti; è il passaggio che lega la misurazione tecnica alla responsabilità politica e alla trasparenza verso il legislatore regionale. ↑
546. Manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi (2008): articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione delle variabili alla normalizzazione, alla ponderazione e all'analisi di robustezza. ↑
547. Benessere Equo e Sostenibile (BES), ISTAT: dodici domini con indici compositi; con la legge n. 163/2016 di riforma del bilancio, una selezione di indicatori è entrata nel ciclo della programmazione economica, a precedente istituzionale dell'impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica. ↑

548. Regole di coerenza e di non duplicazione: il divieto di doppia contabilizzazione impone che, nel medesimo calcolo, una grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali già adottata nella Parte E. ↑
549. Canale dei ricoveri e della specialistica: i sintomi somatici funzionali rappresentano circa il 20% delle consultazioni e si associano a un consumo di prestazioni molto superiore alla media, con riduzioni dei costi superiori al 30% dopo intervento psicologico breve; per la Lombardia il risparmio diretto è dell'ordine di 22-58 milioni di euro, il canale più consistente. ↑
550. Canale della mobilità: a differenza della Puglia, la Lombardia presenta un saldo di mobilità attivo, dell'ordine di 580 milioni di euro, ed è il primo polo attrattivo del Paese; il canale del recupero della mobilità passiva non si applica, e il relativo risparmio diretto è pertanto nullo. È la principale ragione per cui il saldo diretto lombardo è più sfavorevole di quello pugliese. ↑
551. Saldo diretto: aggregati i canali, i risparmi diretti per il Servizio sanitario regionale sono dell'ordine di 35, 60 e 90 milioni di euro secondo lo scenario, a fronte di un costo del servizio di 60, 95 e 120 milioni; il saldo diretto è dunque negativo, dell'ordine di -25, -35 e -30 milioni di euro. ↑
552. Contesto di bilancio: il finanziamento del Servizio sanitario regionale lombardo è dell'ordine di 21 miliardi di euro, il più alto d'Italia, con conti in sostanziale equilibrio e senza piano di rientro; il costo del servizio, anche a massima copertura, ne costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale. La questione non è dunque la sostenibilità della spesa, ma il suo dimensionamento. ↑
553. Ritorno sociale (metodo SROI): fondato sui sette principi del valore sociale e su una mappa dell'impatto, con proxy finanziari e con le correzioni per peso morto, attribuzione, spostamento e decadimento, a misura del valore sociale generato distintamente dai risparmi di bilancio. ↑
554. Ricadute economico-sociali: la riduzione dell'assenteismo, il recupero di produttività e di funzionamento, la diminuzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati e il minor carico familiare, riferiti ai due milioni di persone con disagio comune, sono stimati in 190, 360 e 560 milioni di euro l'anno secondo lo scenario; la dimensione assoluta è la maggiore del Paese, in ragione di una popolazione in età lavorativa e di una produttività senza pari. ↑
555. Quadro complessivo per scenario: sommando i risparmi diretti e le ricadute sociali, il ritorno complessivo è di 225, 420 e 650 milioni di euro l'anno; al netto del costo, il saldo complessivo è di +165, +325 e +530 milioni, con un rapporto beneficio-costi dell'ordine di 3,8-5,4 a uno, coerente con quello pugliese e con la letteratura internazionale. ↑
556. Distinzione tra caso economico e caso finanziario (Five Case Model): il caso economico misura il valore per la collettività, qui ampio (rapporto beneficio-costi di 3,8-5,4 a uno); il caso finanziario misura la spesa per il bilancio sanitario, qui un saldo diretto negativo ma di entità modesta rispetto a un finanziamento di 21 miliardi. La proposta è forte sul caso economico, sostenibile sul caso finanziario. ↑
557. Robustezza: il segno del saldo complessivo è positivo in tutti gli scenari, comprese le ipotesi conservative; le analisi di sensibilità deterministica e probabilistica e il valore dell'informazione sono sviluppati nella Parte F. ↑
558. Natura dei dati: i parametri dei canali sono in parte ancora ricostruiti per quota di popolazione (17,0%) e saranno sostituiti dai valori certificati che le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali sono chiamate a fornire; le cifre sono ipotesi che lo studio è chiamato a verificare. ↑
559. Collaborative Care Model (sviluppato presso l'Università di Washington, validato da oltre novanta studi randomizzati controllati): équipe integrata di medico di base, responsabile dell'assistenza con formazione in salute mentale e psichiatra consulente per i casi complessi, con screening sistematico, interventi strutturati e monitoraggio degli esiti. ↑

560. Programma inglese di terapie psicologiche (Improving Access to Psychological Therapies, dal 2008, oggi NHS Talking Therapies): modello di cura a intensità crescente che ha reso operativo su larga scala l'intervento psicologico nelle cure primarie, con misurazione dell'esito a ogni seduta e soglie di recupero come riferimento di efficacia. ↑
561. Modello olandese che integra gli psicologi nelle cure primarie (POH-GGZ): prevede tipicamente cinque-otto sedute di intervento psicologico breve fondato sull'evidenza, con invio ai servizi specialistici solo per i quadri più complessi, dell'ordine del quindici per cento. ↑
562. Quadro strategico dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa (aprile 2025): indica l'integrazione di professionisti dedicati nei team di cure primarie tra le strategie cardine per il potenziamento della salute mentale; il modello lombardo ne costituisce un'applicazione su scala regionale. ↑
563. Strumenti di esito standardizzati: il PHQ-9 per i sintomi depressivi (sensibilità 88%, specificità 85%) e il GAD-7 per i sintomi d'ansia (sensibilità 89%, specificità 82%), somministrati all'ingresso e lungo il percorso nei soli punteggi complessivi, a misura oggettiva del miglioramento clinico e del tasso di recupero. ↑
564. Sicurezza del percorso e tutela della persona: sono esclusi dal primo livello i quadri gravi o acuti, ai quali è garantito l'invio appropriato ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante; le situazioni di rischio per sé o per altri sono indirizzate con priorità, senza che lo studio o la cartella registrino il dettaglio delle modalità, a garanzia di sicurezza clinica e di dignità della persona. ↑
565. Articolazione degli esiti: esito primario, costituito dalla quota di miglioramento clinico e dal tasso di recupero; esiti clinici secondari (remissione, riduzione dei punteggi, soddisfazione e qualità di vita); esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, colloqui per persona, tasso di invio appropriato); esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso connessi, psicofarmaci, consulti e ricoveri evitabili). ↑
566. ↑
567. Articolazione degli esiti: esito primario, costituito dalla quota di miglioramento clinico e dal tasso di recupero; esiti clinici secondari (remissione, riduzione dei punteggi, soddisfazione e qualità di vita); esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, colloqui per persona, tasso di invio appropriato); esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso connessi, psicofarmaci, consulti e ricoveri evitabili). Questa parte conclusiva applica la griglia di giudizio del telaio, i criteri dell'OCSE-DAC, che attraversano l'intero studio come metro di valutazione e convergono qui nella sintesi; fornisce inoltre il contenuto del caso strategico del Five Case Model. ↑
568. Criteri di valutazione dell'OCSE-DAC (rivisti nel 2019, «Better Criteria for Better Evaluation»): sei lenti complementari — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità — che insieme danno un quadro complessivo dell'intervento. ↑
569. Rilevanza: l'intervento risponde a un bisogno reale e di grande dimensione — dell'ordine di due milioni di persone con disagio comune in larga parte inevaso, il più ampio bacino del Paese — e all'obbligo di garantire i livelli essenziali. ↑
570. Coerenza: l'intervento è compatibile e complementare con gli standard dell'assistenza territoriale (DM 77/2022), con la Missione 6 del PNRR e con la legge regionale n. 22 del 2021, ed è costituzionalmente difendibile; la Lombardia, non sottoposta a piano di rientro, non incontra il vincolo di bilancio che grava sulle regioni in disavanzo. ↑
571. Efficacia: l'evidenza internazionale documenta che i modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie raggiungono gli obiettivi clinici, con tassi di recupero dell'ordine del 50% nel programma inglese. ↑

572. Efficienza: l'intervento è favorevole in termini di costo-utilità — con dominanza per paziente e costo-efficacia confermata dall'analisi probabilistica — a fronte, per la Lombardia, di un saldo diretto negativo sul solo bilancio sanitario, di entità modesta rispetto a un finanziamento di 21 miliardi; l'efficienza allocativa è dunque elevata, la convenienza per il solo bilancio negativa. ↑
573. Impatto: l'impatto distributivo è favorevole, poiché i benefici si concentrano dove l'accesso è più difficile — le aree alpine e le popolazioni gravate dalle liste di attesa — riducendo il gradiente territoriale; il ritorno complessivo è dell'ordine di 3,8-5,4 a uno. ↑
574. Sostenibilità: l'intervento è finanziariamente sostenibile — a fronte di un costo modesto, di una pluralità di coperture e di un bilancio regionale in equilibrio — e organizzativamente, in quanto istituzionalizzato nella rete territoriale prevista dalla riforma del 2021. ↑
575. Analisi multi-criterio (buone pratiche ISPOR): rende esplicito il bilanciamento dei criteri non riducibili a denaro — l'equità, la fattibilità, la coerenza strategica, la robustezza dell'evidenza — attribuendo a ciascuno un peso e a ciascuna opzione un punteggio. ↑
576. Risultato dell'analisi multi-criterio: su otto criteri pesati, l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 80,7 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri tranne la fattibilità immediata; il risultato è stabile rispetto ai pesi adottati. ↑
577. Le tre affermazioni del cruscotto decisionale per la Lombardia: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, trascurabile rispetto a un finanziamento di 21 miliardi; il ritorno per la collettività è ampio (rapporto beneficio-costi di 3,8-5,4 a uno); il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali. ↑
578. Raccomandazione centrale: la decisione rilevante non è se prevedere il servizio — già previsto dalla legge regionale n. 22 del 2021 — ma se strutturarne e dimensionarlo, portandolo dalla previsione alla copertura del fabbisogno, dell'ordine di 2.190 incarichi. ↑
579. Cruscotto secondo il Quintuple Aim: la sintesi del valore è letta lungo le cinque dimensioni dell'esito di salute, dell'esperienza, del costo, del benessere degli operatori e dell'equità. ↑
580. Limite principale (radicamento nei dati): le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione lombarda (17,0%), e non estratte dai conti regionali certificati; tale sostituzione è la condizione per la presentazione agli organi di controllo. ↑
581. Cautele di trasferibilità e di fonte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la cifra del ritorno è prudenziale e non ponderata per l'equità. ↑
582. Agenda di ricerca: l'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, seguito dall'avvio della rilevazione di servizio e dalla valutazione controfattuale sul dispiegamento scaglionato. ↑
583. Protezione dei dati nei sistemi informativi: la progettazione rispetta la disciplina europea e nazionale su protezione dei dati, dispositivi medici e intelligenza artificiale, con sicurezza, trasparenza e minimizzazione; al sistema di monitoraggio sono trasmessi esclusivamente dati aggregati e anonimi, dai quali non è possibile risalire alla persona. ↑
584. Intelligenza artificiale e dispositivi digitali: strumenti digitali e sistemi di IA a supporto di diagnostica, prevenzione, trattamento e continuità assistenziale, e dispositivi terapeutici digitali validati, impiegati quali ausili e non in sostituzione del professionista, con sorveglianza umana costante. In Lombardia tale impiego si allinea alla previsione regionale di strumenti di intelligenza artificiale nelle Centrali Operative Territoriali introdotte dalla riforma del 2021. ↑

585. Funzioni degli strumenti digitali e di IA: triage psicologico assistito, screening automatico, strumenti predittivi del rischio, supporto decisionale clinico non vincolante, riduzione del carico amministrativo mediante automazione appropriata, analisi del linguaggio naturale con validazione, supervisione e spiegabilità. ↑
586. Telepsicologia: modalità integrativa di erogazione, complementare e non sostitutiva rispetto all'intervento in presenza, finalizzata ad ampliare l'accesso; in Lombardia assume particolare rilievo per le aree alpine di Sondrio e delle valli prealpine, a popolazione anziana e dispersa, dove lo spostamento è difficoltoso. ↑
587. Dispositivi terapeutici digitali (DTx): software-intervento validato da studi controllati e prescritto dal clinico, distinto dalle applicazioni di benessere, con modelli di rimborso già consolidati in altri Paesi europei; offrono per i disturbi comuni strumenti a efficacia documentata. ↑
588. Cautele d'impiego degli strumenti digitali: l'evidenza, disomogenea e in evoluzione, impone selezione, validazione locale e gradualità; la protezione dei dati richiede sicurezza informatica e consenso chiaro; l'equità digitale impone di garantire sempre l'alternativa dell'intervento in presenza alle persone anziane, fragili o a bassa competenza digitale; la supervisione clinica resta la condizione ultima dell'impiego responsabile. ↑
589. Programma formativo a quattro livelli: universitario, post-universitario specialistico, continuo in ambito lavorativo e di affiancamento operativo, con una componente trasversale dedicata all'intelligenza artificiale applicata alle cure primarie, realizzato con le università, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sotto l'indirizzo del livello regionale. ↑
590. Dimensione del programma formativo in Lombardia: la popolazione professionale destinataria è la più numerosa del Paese, comprendendo l'ordine di 2.190 psicologi di base a regime e una popolazione di medici di medicina generale dell'ordine di 6.000-6.400 unità, per un totale dell'ordine di 8.000-8.700 professionisti; la formazione è scaglionata in corrispondenza delle fasi di attivazione del servizio per Agenzia di Tutela della Salute. ↑
591. ↑
592. Dimensione del programma formativo in Lombardia: la popolazione professionale destinataria è la più numerosa del Paese, comprendendo l'ordine di 2.190 psicologi di base a regime e una popolazione di medici di medicina generale dell'ordine di 6.000-6.400 unità, per un totale dell'ordine di 8.000-8.700 professionisti; la formazione è scaglionata in corrispondenza delle fasi di attivazione del servizio per Agenzia di Tutela della Salute. Questa parte sviluppa i metodi di modellazione e di gestione dell'incertezza del quinto dominio, secondo le buone pratiche di ricerca sulla modellazione dell'ISPOR e dell'Accademia delle scienze, e è riportata secondo lo standard CHEERS 2022. ↑
593. Modello di Markov a coorte, strumento standard della valutazione economica in sanità: rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi (sintomatico, recupero, cronico, morte), scanditi da cicli con correzione di metà ciclo; la microsimulazione ne costituisce la variante per le traiettorie individuali. ↑
594. Risultati del caso base (singolo paziente, orizzonte di cinque anni, valori scontati): il braccio dell'intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un'utilità di 3,627 anni di vita ponderati, contro un costo di circa 3.799 euro e un'utilità di 3,392 dell'assistenza usuale; l'intervento è quindi meno costoso (di circa 1.304 euro) e più efficace (di circa 0,236 anni), configurando una dominanza. ↑
595. La dominanza si spiega con la struttura del modello: a fronte di un costo iniziale contenuto, l'intervento accresce il tempo trascorso nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce il tempo trascorso nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte. Il

risultato per paziente è il fondamento microeconomico delle stime aggregate della Parte E ed è indipendente dalla regione. ↑

596. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. ↑
597. ↑
598. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudenziale per l'ottimismo delle stime. ↑
599. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
600. Quadro economico consolidato per la Lombardia (Parte E): a regime, da circa 1.100 a circa 2.190 psicologi, costo del servizio di 60-120 milioni, risparmi diretti di 35-90 milioni, ricadute sociali di 190-560 milioni; il saldo diretto è negativo, il saldo complessivo positivo, con rapporto beneficio-costi di 3,8-5,4 a uno. ↑
601. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
602. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio. ↑
603. Valori regionali di ancoraggio per la Lombardia: popolazione di 10.033.918 abitanti (Censimento ISTAT 2024), finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 21 miliardi di euro con conti in equilibrio, saldo di mobilità attivo, fabbisogno a regime dell'ordine di 2.190 psicologi. ↑
604. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione lombarda (17,0%), e non estratti dai conti regionali certificati; i dati da acquisire presso le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali sono elencati nella tabella seguente. ↑
605. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑
606. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni allo studio pugliese, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑
607. Analisi di sensibilità a una via: ciascun parametro è fatto variare del 25% in più e in meno, misurandone l'effetto sul beneficio monetario netto; il diagramma a tornado ordina i parametri per influenza, con l'efficacia clinica, i tassi di ricaduta e di cronicizzazione e il costo dello stato cronico tra i più influenti. ↑
608. Incertezza strutturale: oltre all'incertezza dei parametri, l'incertezza sulla struttura e sulle assunzioni del modello è trattata mediante analisi di scenario, e i risultati sono riportati secondo lo standard CHEERS, con validazione della coerenza interna ed esterna. ↑
609. Analisi di sensibilità probabilistica: il modello è eseguito diecimila volte con estrazione casuale dei parametri dalle rispettive distribuzioni (simulazione Monte Carlo), propagando l'incertezza dei parametri sull'incertezza del risultato. ↑

610. Soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, valore di riferimento nella prassi italiana e internazionale. [↑](#)
611. Curva di accettabilità della costo-efficacia: alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è dell'88,9% e la probabilità che sia dominante dell'84,6%; il beneficio monetario netto medio sulle diecimila iterazioni è di circa 7.815 euro per paziente, con intervallo di credibilità al 95% da circa -5.736 a circa +21.501 euro. [↑](#)
612. Distinzione tra costo-utilità e impatto sul bilancio per la Lombardia: la probabilità di costo-efficacia è un risultato di efficienza, riferito al singolo paziente, che valorizza il guadagno di salute e l'intera traiettoria di costo del modello; esso è coerente con il saldo diretto aggregato della Parte E, che per la Lombardia è negativo, poiché la traduzione dal modello per paziente all'aggregato regionale incorpora le correzioni per peso morto e per l'effettiva monetizzabilità nel bilancio dei costi evitati, e poiché manca il canale della mobilità. L'efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali. [↑](#)
613. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. [↑](#)
614. [↑](#)
615. Posizione del Trentino-Alto Adige: il territorio regionale è ripartito in due Province autonome — Trento e Bolzano — ciascuna titolare di piena competenza legislativa in materia di igiene e sanità e dotata di un proprio Servizio sanitario, distinto e autonomo. La sanità è dunque materia provinciale, non regionale: in Trentino opera l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), in Alto Adige l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (Sabes). Entrambe le Province dispongono già di forme di psicologia territoriale: il Trentino, con una legge provinciale del 2016 — prima esperienza in Italia — ha convenzionato studi psicologici privati con l'APSS per l'erogazione di cicli di sedute in sei ambiti definiti (sostegno ai caregiver, elaborazione del lutto, dolore cronico non oncologico, sintomi ansioso-depressivi, stress lavorativo), su invio dell'Azienda e con un ticket a carico del paziente; l'Alto Adige dispone di un Servizio psicologico territoriale pubblico, organizzato per comprensori sanitari e composto da psicologi di madrelingua tedesca e italiana. Non esiste, allo stato, un modello unico di psicologo di base esteso e armonizzato fra le due Province. [↑](#)
616. Valore dell'informazione e priorità di ricerca: l'analisi del valore atteso dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione del Trentino-Alto Adige, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle due aziende sanitarie provinciali e l'impostazione di un flusso uniforme e interoperabile dei dati di esito fra le due Province, valorizzando i dati già disponibili dagli assetti esistenti. [↑](#)
617. Mitigazione progressiva della lacuna: il Trentino-Alto Adige consolida l'evidenza locale a partire dagli assetti già operanti, che offrono una base di dati propri più estesa che altrove; impostando un flusso uniforme e interoperabile fra le due Province, l'evidenza locale corregge progressivamente le stime importate dai benchmark, conducendo il territorio da una valutazione fondata in parte su dati esterni a una fondata in misura crescente su dati propri. [↑](#)
618. Sintesi della modellazione: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione e consolidamento dei dati, e la condizione di territorio con assetti già operanti — dotato di una base di dati propri più estesa che altrove — consente di affinare la prova empirica oltre i soli benchmark, valorizzando una rilevazione uniforme e interoperabile fra le due Province. [↑](#)

619. Disagio giovanile: è la componente più caratterizzante del Trentino-Alto Adige, fra le regioni più giovani d'Italia. Ansia, depressione e disturbi del comportamento alimentare fra adolescenti e giovani adulti, accentuati dalla pressione scolastica e prestazionale, costituiscono una domanda crescente; l'intercettazione precoce ha un valore particolarmente elevato in termini di salute e di equità, e la presenza di atenei e di una popolazione studentesca rilevante a Trento e Bolzano ne accresce la portata. ↑
620. Disagio giovanile e connesso al lavoro: in una popolazione fra le più giovani d'Italia, la pressione scolastica e prestazionale concorre al disagio psichico, con fenomeni di ansia, depressione e disturbi del comportamento alimentare tra gli adolescenti e i giovani adulti, accanto allo stress lavorativo proprio di un'economia ad alta attività; l'intercettazione precoce ha un valore particolarmente elevato in termini di salute e di equità, e la presenza di atenei e di una popolazione studentesca rilevante a Trento e Bolzano ne accresce la portata. ↑
621. Bisogno connesso al lavoro e accesso nelle valli: in un'economia ad alta attività e a pieno impiego, lo stress lavorativo e i disturbi correlati costituiscono una componente rilevante della domanda, accanto a quella connessa all'isolamento nelle valli alpine a popolazione dispersa, dove le distanze e l'orografia generano difficoltà di accesso; è un fattore di bisogno specifico del territorio montano, che un primo livello accessibile, sostenuto dalla telepsicologia, può in parte intercettare. ↑
622. Tratto distintivo del Trentino-Alto Adige rispetto alle altre regioni: la combinazione di un territorio ripartito in due Province autonome con Servizi sanitari distinti e pienamente autonomi, di forme di psicologia territoriale già operanti in entrambe — il modello trentino di convenzione (legge 2016, prima esperienza italiana) e il Servizio psicologico dell'Alto Adige — di una popolazione fra le più giovani, ricche e sane d'Italia, e di una piena autonomia finanziaria che, a differenza di Sicilia e Sardegna, opera in avanzo e non in disavanzo. A questo si aggiunge il plurilinguismo, con la tutela costituzionale dei gruppi linguistici. Il bisogno è quindi accompagnato da assetti già operanti, ma non ancora strutturati in un modello pieno e armonizzato, che la decisione è chiamata a comporre. ↑
623. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche: rapportando alla popolazione del Trentino-Alto Adige il dato nazionale, dell'ordine di alcune migliaia l'anno; pur contenuti da un sistema di cure primarie già ben dotato, indicano una pressione che un primo livello territoriale pienamente strutturato potrebbe ulteriormente ridurre a monte, tanto più rilevante nelle valli alpine dove le distanze rendono l'accesso al pronto soccorso più oneroso. ↑
624. Offerta territoriale: il Trentino dispone, dal 2016, di un modello di convenzione fra l'APSS e studi psicologici privati — prima esperienza in Italia — che eroga cicli di sedute (di norma da otto a sedici) in sei ambiti definiti, su invio dell'Azienda e con un ticket a carico del paziente; l'Alto Adige dispone di un Servizio psicologico territoriale pubblico, organizzato per comprensori sanitari e composto da psicologi di madrelingua tedesca e italiana. I due assetti, distinti e disciplinati da ordinamenti provinciali autonomi, non sono ancora strutturati in un modello pieno di psicologo di base né armonizzati fra loro. ↑
625. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 240 psicologi nello scenario espansivo (e dell'ordine di 120 e 180 negli scenari conservativo e di base). L'Ordine degli Psicologi della Regione Trentino-Alto Adige e le rappresentanze della categoria ne sostengono la strutturazione in un modello pieno e l'armonizzazione fra le due Province. ↑
626. Copertura attuale del fabbisogno: gli assetti esistenti delle due Province raggiungono una parte della domanda ma non coprono il fabbisogno a regime in un modello pieno. La decisione, di conseguenza, non verte sull'istituire il servizio, già presente in forme diverse, ma sullo strutturarlo in un modello pieno di psicologo di base, armonizzarne gli assetti fra le due Province e dimensionarlo verso la copertura piena, agevolata dall'avanzo di bilancio. ↑

627. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante nel Trentino-Alto Adige si gioca su due assi. Il primo separa i centri urbani di Trento, Bolzano e Merano dalle valli alpine a popolazione dispersa, penalizzate dalle distanze e dall'orografia: è l'asse territoriale. Il secondo, distintivo, è linguistico: l'accesso effettivo richiede che il servizio sia disponibile nella lingua del residente — tedesco, italiano o ladino — secondo la tutela costituzionale dei gruppi. La telepsicologia assistita avvicina l'offerta alle valli, e la disponibilità di personale plurilingue è condizione di equità effettiva. ↑
628. Finanziamento dei Servizi sanitari provinciali: entrambe le Province autonome finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito fiscale trattenuto sul proprio territorio (articolo 75 dello statuto), senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato, e versano allo Stato una quota a contributo del risanamento del debito pubblico. La spesa sanitaria pro-capite è la più elevata d'Italia — in Trentino dell'ordine di 2.160 euro — e la spesa per il personale supera nettamente la media nazionale; i bilanci operano in avanzo. Il sistema, già ampiamente finanziato, lascia margini di consumo improprio più contenuti da recuperare. ↑
629. Mobilità sanitaria: il Trentino-Alto Adige presenta un saldo di mobilità modesto e, per alcune branche, le due Province attraggono pazienti più di quanti ne perdano, grazie a una dotazione e a una qualità dei servizi elevate. La mobilità non riguarda la domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento trascurabile, a differenza delle regioni a forte saldo passivo. ↑
630. Cornice normativa e programmatica: nel Trentino-Alto Adige la competenza sanitaria è provinciale, e i due assetti poggiano su ordinamenti distinti — il modello trentino di convenzione con studi privati, introdotto da una legge provinciale del 2016, e il Servizio psicologico territoriale dell'Alto Adige, organizzato nell'ambito del proprio Servizio sanitario. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera. A differenza delle altre regioni, la decisione non passa per un'unica legge regionale, ma per il coordinamento e l'armonizzazione di due ordinamenti provinciali pienamente autonomi, entro un contesto di piena autonomia finanziaria e di avanzo di bilancio. ↑
631. Popolazione residente in Trentino-Alto Adige dell'ordine di 1.085.000 abitanti (dati ISTAT 2024), pari a circa l'1,8% della popolazione nazionale, ripartita quasi equamente fra le due Province autonome: 545.169 residenti in Trentino e 539.386 in Alto Adige (31 dicembre 2024). A differenza della maggior parte delle regioni, la popolazione è in crescita, sostenuta da una natalità fra le più elevate d'Italia (8,8 nati per mille in Alto Adige, 7,0 in Trentino) e da saldi migratori positivi; la struttura per età è fra le più giovani del Paese. Il tratto demografico distintivo è la composizione linguistica dell'Alto Adige, dove il Censimento linguistico 2024 ha rilevato il 68,61% di appartenenti al gruppo tedesco, il 26,98% al gruppo italiano e il 4,41% al gruppo ladino, con tutela costituzionale e proporzionale etnica; in Trentino la popolazione è prevalentemente italofona, con minoranze ladine, mochene e cimbre. La componente straniera è dell'ordine del 9-10%, superiore alla media delle regioni a statuto speciale. ↑
632. ↑
633. Popolazione residente in Trentino-Alto Adige dell'ordine di 1.085.000 abitanti (dati ISTAT 2024), pari a circa l'1,8% della popolazione nazionale, ripartita quasi equamente fra le due Province autonome: 545.169 residenti in Trentino e 539.386 in Alto Adige (31 dicembre 2024). A differenza della maggior parte delle regioni, la popolazione è in crescita, sostenuta da una natalità fra le più elevate d'Italia (8,8 nati per mille in Alto Adige, 7,0 in Trentino) e da saldi migratori positivi; la struttura per età è fra le più giovani del Paese. Il tratto demografico distintivo è la composizione linguistica dell'Alto Adige, dove il Censimento linguistico 2024 ha rilevato il 68,61% di appartenenti al gruppo tedesco, il 26,98% al gruppo italiano e il 4,41% al gruppo ladino, con tutela costituzionale e proporzionale etnica; in Trentino la popolazione è prevalentemente italofona, con minoranze ladine, mochene e cimbre. La componente straniera è dell'ordine del 9-10%, superiore alla media delle regioni a statuto speciale. Equità come dominio della valutazione: l'analisi

distributiva non è un'appendice, ma un dominio proprio dell'HTA, poiché un intervento può essere efficiente nel complesso e tuttavia accrescere le disuguaglianze, o al contrario ridurle; lo studio impiega l'analisi di costo-efficacia distributiva per misurarne l'effetto sui divari, oltre che sull'efficienza. ↑

634. Gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi; pur in un territorio fra i più ricchi d'Italia, il gradiente sociale opera all'interno delle valli più isolate e fra i gruppi linguistici minoritari, dove l'accesso effettivo dipende dalla disponibilità di un'offerta di prossimità e nella lingua del residente. ↑
635. Barriere all'accesso: il ricorso al sostegno psicologico è ostacolato da barriere geografiche, linguistiche e culturali, oltre che dallo stigma. Nel Trentino-Alto Adige la barriera linguistica e culturale è centrale, e non marginale come in altre regioni: il servizio deve essere disponibile in tedesco, italiano e ladino perché l'accesso sia effettivo per tutti i gruppi. Vi si aggiungono la barriera geografica delle valli alpine a popolazione dispersa e quella generazionale, poiché il disagio giovanile trova negli adolescenti e nei giovani adulti una fascia restia a rivolgersi ai servizi. Quanto alla barriera economica, gli assetti delle due Province sono disomogenei — il modello trentino prevede un ticket, il Servizio dell'Alto Adige è pubblico — e l'armonizzazione in un modello pieno è occasione per ridurre tale disomogeneità fra i residenti dei due territori. ↑
636. Doppio asse della disuguaglianza nel Trentino-Alto Adige: il territorio presenta due assi distinti, cui si aggiunge una dimensione generazionale. Il primo, territoriale, separa i centri urbani di Trento, Bolzano e Merano dalle valli alpine a popolazione dispersa, dove le distanze e l'orografia rendono più oneroso il raggiungimento dei servizi. Il secondo, distintivo e proprio di questo territorio, è linguistico: l'accesso effettivo richiede che il servizio sia disponibile nella lingua del residente — tedesco, italiano o ladino — secondo la tutela costituzionale dei gruppi. A questi si somma il disagio giovanile, prevalente in una popolazione fra le più giovani d'Italia. ↑
637. Primo asse, le valli alpine: le numerose vallate del territorio presentano una popolazione dispersa in piccoli comuni distanti dai centri maggiori, dove l'orografia e le distanze rendono l'accesso al sostegno psicologico più difficoltoso; pur in presenza di servizi di buona qualità, la copertura capillare delle valli richiede un'organizzazione dedicata e il ricorso alla telepsicologia. ↑
638. Secondo asse, la dimensione linguistica: in Alto Adige convivono il gruppo tedesco (68,61%), il gruppo italiano (26,98%) e il gruppo ladino (4,41%), con tutela costituzionale e proporzionale etnica; in Trentino la popolazione è prevalentemente italoфона, con minoranze ladine, mochene e cimbre. L'accesso effettivo al sostegno psicologico richiede che il servizio sia erogato nella lingua del paziente, sicché la disponibilità di personale plurilingue è condizione di equità e non semplice elemento organizzativo. ↑
639. Effetto del servizio sull'equità: la prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano parte delle barriere all'accesso e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso; nel Trentino-Alto Adige il meccanismo pro-equità opera attraverso la prossimità nelle valli, la disponibilità del servizio nella lingua del residente e l'armonizzazione degli assetti fra le due Province, che assicura parità di accesso ai residenti di entrambi i territori — a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno territoriale e linguistico. ↑
640. Telepsicologia assistita: nel Trentino-Alto Adige è lo strumento per avvicinare l'offerta alle valli alpine a popolazione dispersa, dove le distanze e l'orografia rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi, e per mettere a disposizione, anche a distanza, personale della lingua del paziente nelle aree dove la presenza fisica di operatori del gruppo linguistico è più difficile da garantire; concepita come complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, essa estende la copertura proprio dove l'accesso è più difficile. ↑

641. Competenza linguistica e generazionale: nel Trentino-Alto Adige la competenza linguistica è dirimente e centrale, poiché il servizio deve essere erogato in tedesco, italiano e ladino secondo l'appartenenza dei residenti; ad essa si affianca la competenza nell'intercettare il disagio giovanile, prevalente in una delle regioni più giovani d'Italia, affinché il servizio raggiunga adolescenti e giovani adulti, fascia a elevato bisogno e a basso ricorso spontaneo. ↑
642. Costo-efficacia distributiva: l'analisi indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, in quanto i maggiori benefici si concentrano nei residenti delle valli più isolate, nei gruppi linguistici minoritari e nelle fasce giovanili a più elevato bisogno non soddisfatto; l'intervento è quindi favorevole all'equità, oltre che costo-efficace, e l'erogazione nella lingua del residente e l'armonizzazione fra le due Province ne rafforzano la natura pro-equità. ↑
643. Modulazione territoriale e linguistica della copertura: per realizzare il potenziale di equità, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle valli alpine più isolate e garantendo la disponibilità di personale in tedesco, italiano e ladino secondo la composizione dei territori; un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un'allocazione ponderata per il bisogno e per la lingua li riduce. La strutturazione del modello pieno offre l'occasione di orientare fin dall'inizio l'allocazione secondo criteri di equità. ↑
644. Mobilità e equità: nel Trentino-Alto Adige il canale della mobilità è, per questo intervento, una leva di equità trascurabile, poiché le due Province attraggono pazienti più di quanti ne perdano e la mobilità non riguarda la domanda psicologica territoriale; l'equità si gioca quindi prevalentemente sull'accesso interno, fra centri urbani e valli alpine e fra i gruppi linguistici del territorio. ↑
645. Rischio di iniquità inversa: se la strutturazione del modello pieno privilegiasse, per facilità organizzativa, i centri urbani già meglio serviti o un solo gruppo linguistico, l'effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell'allocazione delle sedi e del personale, assicurando la copertura delle valli più isolate e la disponibilità del servizio in tutte le lingue del territorio fin dalle prime fasi. ↑
646. Sintesi dell'equità: l'intervento è favorevole all'equità su entrambi gli assi del divario del Trentino-Alto Adige — territoriale e linguistico — e sulla dimensione generazionale, e l'armonizzazione degli assetti fra le due Province ne rafforza la natura pro-equità riducendo le disomogeneità fra i residenti dei due territori; a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno, che siano garantite la telepsicologia per le valli e l'erogazione nelle diverse lingue, e che si presti attenzione congiunta al disagio giovanile, la raccomandazione è di orientare fin dalla strutturazione del modello un'allocazione pro-equità che dia di più dove il bisogno è maggiore, nelle valli e fra i gruppi linguistici minoritari. ↑
647. Caso di riferimento: doppia prospettiva dei Servizi sanitari provinciali e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; gli assetti esistenti delle due Province — il modello trentino di convenzione con studi privati e il Servizio psicologico territoriale dell'Alto Adige, nella loro forma attuale, non ancora strutturata in un modello pieno e armonizzato — come comparatore. ↑
648. ↑
649. Caso di riferimento: doppia prospettiva dei Servizi sanitari provinciali e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; gli assetti esistenti delle due Province — il modello trentino di convenzione con studi privati e il Servizio psicologico territoriale dell'Alto Adige, nella loro forma attuale, non ancora strutturata in un modello pieno e armonizzato — come comparatore. Metodo della revisione: la sintesi delle prove segue i criteri di

rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche (PRISMA 2020) e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE; sono considerati studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. ↑

650. Studio fondativo del modello collaborativo (IMPACT), pubblicato su JAMA nel 2002: circa il 50% dei pazienti trattati ha conseguito una riduzione di almeno il 50% dei sintomi a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. ↑
651. Meta-analisi su cinquantasette studi controllati (2012): l'integrazione della cura ha prodotto un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard rispetto alla cura usuale. ↑
652. Revisione di quarantadue implementazioni del modello (2024): riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 43% dell'ansia a sei mesi, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. ↑
653. Programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies), dati reali 2023-2024: tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile del 67,8% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su una scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno. ↑
654. Meta-analisi sulle cure integrate: coefficiente standardizzato dell'ordine di -0,11 sui sintomi depressivi, di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante quando applicato a una popolazione ampia. ↑
655. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. ↑
656. Cautela metodologica rilevante: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi (l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero); il valore economico del modello poggia in misura preponderante sui ritorni sociali, non sui risparmi sanitari diretti. Questa cautela è coerente con il profilo del caso economico campano, fondato anch'esso sulle ricadute sociali. ↑
657. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. ↑
658. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. ↑
659. ↑
660. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. Tre profili intrecciati: la fattibilità dell'intervento dipende dal presidio congiunto di un profilo giuridico (la competenza e la forma dell'atto), di un profilo organizzativo (l'assetto e la governance dell'istituzione) e di un profilo etico (le tutele a garanzia dei pazienti); lo studio li tratta unitariamente, poiché una debolezza in uno solo di essi comprometterebbe l'intera operazione. ↑
661. Profilo giuridico e riparto di competenza: nel Trentino-Alto Adige la materia sanitaria è attribuita alle due Province autonome di Trento e Bolzano, titolari di potestà legislativa e di un proprio Servizio sanitario in forza dello statuto speciale di autonomia. La sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — pronuncia fondativa per l'intera materia, originata dal giudizio sulla legge campana, di cui ha riconosciuto la legittimità — conferma la possibilità di disciplinare il servizio nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Entro questa cornice ciascuna Provincia ha esercitato il proprio titolo in modo autonomo: il Trentino con una legge provinciale del 2016 che convenziona studi psicologici privati con l'APSS, l'Alto Adige con l'organizzazione di un Servizio psicologico territoriale nel proprio Servizio sanitario; non esiste, né sarebbe coerente con l'assetto, un'unica legge regionale. ↑

662. Stato legislativo del Trentino-Alto Adige: a differenza del Lazio, ancora privo di disciplina, entrambe le Province dispongono già di forme di psicologia territoriale — il modello trentino di convenzione con studi privati, introdotto da una legge provinciale del 2016, e il Servizio psicologico territoriale dell’Alto Adige. La decisione giuridica rilevante non è quindi l’approvazione di una norma istitutiva, ma la strutturazione del servizio in un modello pieno e la sua armonizzazione fra i due ordinamenti provinciali, ciascuno nell’esercizio della propria autonomia, nel coordinamento con il testo unico nazionale in discussione. ↑
663. Inquadramento del rapporto di lavoro: i due assetti provinciali adottano forme diverse. Il modello trentino è convenzionale e libero-professionale, con studi psicologici privati accreditati e un ticket a carico del paziente, su invio dell’APSS; il Servizio dell’Alto Adige è pubblico, con psicologi del Servizio sanitario provinciale. La strutturazione in un modello pieno e l’armonizzazione fra le due Province dovranno comporre tali differenze — anche quanto alla compartecipazione del paziente — nel rispetto dell’autonomia di ciascuna Provincia e in coordinamento con il testo unico nazionale in discussione. ↑
664. Livelli essenziali di assistenza e finanziamento: la psicologia delle cure primarie non è ancora esplicitamente ricompresa nei livelli essenziali di assistenza nazionali. Entrambe le Province autonome finanziano però integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto sul proprio territorio, senza apporto a carico del Bilancio dello Stato, e operano in avanzo, con la spesa pro-capite più alta d’Italia; il finanziamento del modello pieno è perciò agevolmente disponibile entro l’autonomia di bilancio di ciascuna Provincia, e la questione non è di copertura ma di scelta allocativa, mentre un futuro riconoscimento nei livelli essenziali rafforzerebbe ulteriormente la stabilità. ↑
665. Cornice degli standard territoriali: il Decreto Ministeriale 77 del 2022 definisce gli standard dell’assistenza territoriale e individua nelle Case della Comunità il fulcro dell’integrazione delle cure primarie; il servizio di psicologia delle cure primarie vi si inserisce coerentemente, come uno dei livelli di risposta al bisogno della popolazione. ↑
666. Rapporto con i servizi specialistici: il servizio di psicologia delle cure primarie precede e alleggerisce i Centri di Salute Mentale, intercettando e trattando i quadri lievi e moderati e indirizzando a essi i casi che richiedono cure specialistiche; l’integrazione, e non la sovrapposizione, è il principio che ne governa il rapporto con la rete esistente. ↑
667. Assetto organizzativo: la strutturazione del servizio nel Trentino-Alto Adige si misura con la presenza di due Servizi sanitari provinciali distinti e pienamente autonomi — l’APSS del Trentino e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (Sabes) — articolati in comprensori e distretti, su un territorio montano con valli a popolazione dispersa e con tre lingue da servire; garantire la strutturazione in un modello pieno e l’armonizzazione fra i due sistemi, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna Provincia e della tutela dei gruppi linguistici, è la sfida organizzativa centrale. ↑
668. Governance della strutturazione: il consolidamento del servizio richiede una sede di coordinamento fra le due Province autonome, l’APSS e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (Sabes), i due Assessorati alla salute, l’Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei dell’Università di Trento e della Libera Università di Bolzano; a tale sede spetta definire indirizzi condivisi e impostare un monitoraggio comparabile fra i due sistemi, valorizzando l’esperienza del modello trentino e del Servizio dell’Alto Adige, nel rispetto della piena autonomia di ciascuna Provincia. ↑
669. Ruolo dell’Ordine professionale: l’Ordine degli Psicologi della Regione Trentino-Alto Adige concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione — comprese le competenze linguistiche per l’erogazione in tedesco, italiano e ladino — e alla vigilanza deontologica; la sua collaborazione è condizione della qualità e dell’appropriatezza del servizio in entrambe le Province. ↑

670. Profilo etico, tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici; è una cautela che presidia l'intervento presso le fasce più fragili. ↑
671. Consenso e riservatezza: l'intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un'informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell'efficacia stessa del sostegno psicologico. ↑
672. Strumenti di intelligenza artificiale e quadro europeo: gli strumenti digitali eventualmente impiegati sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
673. Protezione dei dati personali: il trattamento è conforme alla normativa vigente, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑
674. Responsabilità professionale: il professionista resta pienamente responsabile delle decisioni cliniche, e gli strumenti di supporto, anche quelli basati sull'intelligenza artificiale, forniscono un ausilio non vincolante; la chiarezza sull'imputazione della responsabilità è condizione di un impiego sicuro e appropriato della tecnologia. ↑
675. Sintesi dei profili: i tre profili — giuridico, organizzativo ed etico — nel Trentino-Alto Adige sono presidiati, e la condizione abilitante dell'intervento non è, per la Sicilia, l'approvazione della legge, già in vigore, né l'emanazione del decreto attuativo, già emanato, ma il passaggio dall'avvio al regime: la stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro e dello statuto speciale e la formazione degli elenchi provinciali fra le nove Aziende; è questo il passaggio da cui dipende la piena operatività del servizio, che il coordinamento con il futuro testo unico nazionale potrà rafforzare. ↑
676. Benchmark statunitense (Collaborative Care): modello a équipe integrata, validato da oltre novanta studi controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri. ↑
677. Esperienze italiane: il quadro nazionale comprende i servizi avviati nelle regioni dotate di legge — fra cui la Campania, prima a istituire e attivare il servizio — e le esperienze pilota fondate su campioni limitati e letteratura grigia. Il Trentino-Alto Adige, che dispone già in entrambe le Province di forme di psicologia territoriale — il modello trentino di convenzione con studi privati, attivo dal 2016, e il Servizio psicologico territoriale dell'Alto Adige — si colloca in questo quadro come territorio dotato di esperienza operativa propria più estesa che altrove: la base di dati di esito, già alimentata dagli assetti esistenti, costituisce un punto di partenza solido per la valutazione del modello pieno. ↑
678. Trasferibilità: i risultati internazionali provengono da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale; la loro trasposizione richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche. ↑
679. Evidenza locale del Trentino-Alto Adige: l'evidenza locale poggia su una base operativa più solida di quella delle regioni che partono da zero, grazie agli assetti già operanti nelle due Province. Lo studio impiega, per l'efficacia, i benchmark internazionali, e affina le stime con i dati propri del modello trentino di convenzione e del Servizio psicologico dell'Alto Adige; la strutturazione in un modello pieno consente di consolidare una rilevazione uniforme e interoperabile fra le due Province, presupposto di un'evidenza locale ancora più robusta da costruire a regime. ↑

680. Condizioni del Trentino-Alto Adige per la trasferibilità e la valutazione: il territorio dispone degli assetti già operanti nelle due Province, delle infrastrutture informatiche delle due aziende sanitarie provinciali e della rete delle Case della Comunità in costruzione; la condizione propria, qui, è di affinare le stime importate sui dati già disponibili e di impostare una rilevazione uniforme e interoperabile fra le due Province, tenendo conto del contesto plurilingue, così da generare dati propri solidi a regime. ↑
681. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative: il rapporto di 4:1 spesso citato e l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio sono semplificazioni a fini divulgativi; lo stesso vale per il rapporto di 2,5:1 talvolta richiamato in ambito regionale. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costo complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8:1-5,5:1. ↑
682. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. Il profilo finanziario del Trentino-Alto Adige è il più favorevole della serie: entrambe le Province autonome finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito fiscale trattenuto sul proprio territorio, senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato, e operano in avanzo, con la spesa sanitaria pro-capite più elevata d'Italia. Il vincolo, qui, non è la scarsità di risorse ma il suo rovescio: poiché il sistema è già ampiamente finanziato ed efficiente, il margine di consumo improprio recuperabile è più contenuto che altrove, e il costo unitario del personale è fra i più alti del Paese; sul versante della mobilità, il saldo passivo è modesto e le due Province attraggono pazienti più di quanti ne perdano, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento trascurabile. Ne consegue un saldo diretto negativo — più sfavorevole che nelle regioni sotto-finanziate, proprio perché il sistema lascia minori margini di recupero — ma di entità modesta e agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo; il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi e sostenute da un'elevata produttività e da redditi fra i più alti d'Europa. ↑
683. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (1,8%) e non estratti dai conti provinciali certificati delle due aziende sanitarie provinciali: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare prima della presentazione esterna. Il Trentino-Alto Adige dispone tuttavia, grazie agli assetti già operanti nelle due Province, di una base di dati propri più solida di quella delle regioni che partono da zero; lo studio poggia, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, e li affina con i dati del modello trentino di convenzione e del Servizio psicologico dell'Alto Adige, da consolidare in forma comparabile fra le due Province. ↑
684. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
685. Valutazione controfattuale d'impatto: poiché la strutturazione del modello pieno avverrà in tempi differenziati fra i comprensori e i distretti delle due Province, il disegno può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione fra i territori sono impiegati a fini valutativi. L'effetto causale è stimato con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico; l'esperienza trentina di convenzione con studi privati, attiva dal 2016, e il Servizio psicologico territoriale dell'Alto Adige forniscono una base di dati operativi propri più solida di quella delle regioni che partono da zero, utile a calibrare le stime importate dai benchmark. ↑
686. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo che riunisce le due Province autonome di Trento e Bolzano, i rispettivi Assessorati alla salute, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) del Trentino e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (Sabes), l'Ordine degli Psicologi della Regione Trentino-Alto Adige, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei dell'Università di Trento e della Libera Università di Bolzano. La caratteristica propria del Trentino-Alto Adige è che la

materia sanitaria è di competenza provinciale, non regionale, e che i due Servizi sanitari sono distinti e autonomi: la sfida del governo non è quindi istituire il servizio, né dispiegarlo entro un'unica azienda, ma strutturarlo in un modello pieno e garantirne l'armonizzazione fra due sistemi sanitari pienamente autonomi e fra le diverse lingue del territorio. ↑

687. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce l'infrastruttura per la raccolta uniforme. ↑
688. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
689. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. ↑
690. ↑
691. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. I cinque casi della decisione di investimento pubblico: lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile; la convergenza dei cinque casi è condizione della solidità della decisione. ↑
692. Caso strategico: la strutturazione del servizio è coerente con la cornice nazionale degli standard territoriali, con la centralità delle Case della Comunità e con la programmazione provinciale per la salute mentale; nel Trentino-Alto Adige essa presenta una coerenza ulteriore, poiché porta a un modello pieno gli assetti che le due Province autonome già esercitano — il modello trentino di convenzione e il Servizio psicologico dell'Alto Adige — armonizzandoli. ↑
693. Caso economico: rinvia ai risultati della valutazione economica — un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 4,1-5,5 a uno e una dominanza per paziente con elevata probabilità — nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di disavanzo modesto, agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo, e un caso sociale fortemente positivo. ↑
694. Caso commerciale: gli assetti già operanti dispongono di una rete di professionisti — gli studi convenzionati in Trentino e gli psicologi del Servizio dell'Alto Adige — e si avvalgono di un bacino alimentato dall'Università di Trento e dalla Libera Università di Bolzano; la disponibilità di psicologi qualificati, anche con competenze linguistiche in tedesco, italiano e ladino, non costituisce un vincolo alla strutturazione del modello pieno. ↑
695. Caso finanziario: il costo del servizio a regime — dell'ordine di 7, 11 e 14 milioni di euro nei tre scenari, pari allo 0,3-0,5% della spesa sanitaria — è contenuto, e il suo reperimento è qui il punto più favorevole della serie: entrambe le Province autonome finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto, senza apporto a carico dello Stato, e operano in avanzo, con la spesa pro-capite più alta d'Italia. La sfida finanziaria non è reperire la copertura, agevolmente disponibile entro l'autonomia di ciascuna Provincia, ma operare la scelta allocativa. ↑

696. Caso gestionale: la realizzabilità dipende da una sede di coordinamento fra le due Province autonome che raccordi l'APSS e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (Sabes), i due Assessorati alla salute, l'Ordine professionale, la medicina generale e la pediatria di libera scelta e gli atenei di Trento e Bolzano; a tale sede spetta definire indirizzi condivisi e impostare un monitoraggio comparabile fra i due sistemi, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna Provincia. ↑
697. Dimensionamento a partire dagli assetti esistenti: a differenza del Lazio, che deve dimensionare il servizio da zero, il Trentino-Alto Adige muove dagli assetti già operanti nelle due Province e li struttura verso un fabbisogno a regime dell'ordine di 240 psicologi nello scenario espansivo; la strutturazione procede per gradi attraverso gli scenari conservativo, di base ed espansivo, armonizzando progressivamente i due sistemi. ↑
698. Fasi di attuazione: l'attuazione si articola in una fase di strutturazione, con la definizione del modello pieno a partire dagli assetti esistenti; una fase di armonizzazione, nella quale i due ordinamenti provinciali vengono progressivamente allineati; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato al fabbisogno. La progressione differenziata fra i comprensori delle due Province coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F. ↑
699. Reclutamento e formazione: l'avvio a regime richiede il reclutamento e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino professionale e gli atenei dell'Università di Trento e della Libera Università di Bolzano costituiscono una base favorevole, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze, con particolare attenzione al disagio giovanile e alle competenze linguistiche in tedesco, italiano e ladino. ↑
700. Cronoprogramma: l'attuazione si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; la strutturazione non è subordinata all'approvazione di una legge regionale, ma alla definizione del modello pieno e alla sua armonizzazione fra i due ordinamenti provinciali, agevolata dalla piena autonomia finanziaria e dall'avanzo di bilancio delle due Province. ↑
701. Sostenibilità finanziaria: la leva della sostenibilità, nel Trentino-Alto Adige, è la più solida della serie: entrambe le Province autonome finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto, senza apporto statale, e operano in avanzo, con la spesa pro-capite più alta d'Italia, sicché il costo del modello pieno è agevolmente sostenibile entro l'autonomia di ciascuna Provincia; l'eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe in futuro la stabilità. ↑
702. Sostenibilità organizzativa: la sfida è garantire la strutturazione in un modello pieno e l'armonizzazione fra i due Servizi sanitari provinciali, su un territorio montano e plurilingue; la sostenibilità organizzativa dipende dalla forza della sede di coordinamento fra le due Province e dalla chiarezza degli indirizzi condivisi, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna Provincia. ↑
703. Monitoraggio dell'attuazione: l'avanzamento è seguito mediante indicatori di processo — sedi attivate, psicologi inquadrati, prese in carico — raccolti attraverso un sistema impostato in forma comparabile e interoperabile fra le due Province, valorizzando i dati già disponibili dal modello trentino e dal Servizio dell'Alto Adige. ↑
704. Rischi principali dell'attuazione: la difficoltà di armonizzare due Servizi sanitari provinciali pienamente autonomi, con ordinamenti e assetti diversi; il maggior costo unitario del personale, fra i più alti del Paese; la necessità di garantire l'erogazione in tre lingue; e il rischio che la strutturazione privilegi i centri urbani a scapito delle valli alpine o un solo gruppo linguistico. ↑
705. Mitigazioni: i rischi sono fronteggiati con una sede di coordinamento fra le due Province e indirizzi condivisi, con la valorizzazione degli assetti già operanti che consente un apprendimento progressivo, e con un'allocatione pro-equità che orienta la strutturazione verso le valli a maggiore bisogno e garantisce

l'erogazione in tutte le lingue del territorio; l'avanzo di bilancio e il sostegno dell'Ordine professionale concorrono a ridurre l'incertezza. ↑

706. Sintesi dell'attuazione: l'intervento è attuabile e sostenibile, e la leva propria del Trentino-Alto Adige è la strutturazione del servizio in un modello pieno e la sua armonizzazione fra i due ordinamenti provinciali; il territorio muove da assetti già operanti in entrambe le Province, da un bacino professionale adeguato e dalla piena autonomia finanziaria, con bilanci in avanzo, sicché le condizioni di fattibilità sono fra le più favorevoli della serie. ↑

707. Struttura per età: il Trentino-Alto Adige è fra le regioni più giovani d'Italia, con una speranza di vita fra le più elevate del Paese — in Trentino superiore alla media nazionale di circa 6,7 anni — e con la provincia di Bolzano leggermente più giovane di quella di Trento, per effetto di una natalità più alta. La componente anziana, pur in crescita come ovunque, è accompagnata da indicatori di salute e di autonomia funzionale fra i migliori d'Italia, sicché il carico della cronicità grava meno che nelle regioni più anziane. ↑

708. Dimensione linguistica e culturale: a differenza delle altre regioni, nel Trentino-Alto Adige la competenza linguistica è un tratto strutturale e costituzionalmente tutelato. Il Censimento linguistico 2024 dell'Alto Adige ha rilevato il 68,61% di appartenenti al gruppo tedesco, il 26,98% al gruppo italiano e il 4,41% al gruppo ladino, con proporzionale etnica nella ripartizione delle risorse e nelle assunzioni pubbliche; in Trentino la popolazione è prevalentemente italoфона, con minoranze ladine, mocheni e cimbri. La componente straniera, dell'ordine del 9-10%, si aggiunge a un quadro in cui il servizio deve essere erogato nelle diverse lingue del territorio. ↑

709. Distribuzione territoriale: la popolazione si ripartisce fra due Province autonome di dimensione simile e si addensa nei centri urbani — Trento e Bolzano, ciascuna intorno ai centomila abitanti, e Merano — mentre una quota rilevante risiede in comuni di piccola dimensione disseminati nelle valli alpine. La conformazione montana, con vallate distinte e spesso distanti dai centri maggiori, è il tratto geografico che più condiziona l'organizzazione e l'accesso ai servizi territoriali. ↑

710. Profilo territoriale: da un lato i centri urbani di Trento, Bolzano e Merano, che concentrano popolazione e servizi; dall'altro le numerose valli alpine a popolazione dispersa, dove le distanze e l'orografia rendono più oneroso il raggiungimento dei servizi. A questo asse territoriale si sovrappone, in Alto Adige, quello linguistico, poiché l'offerta deve essere garantita in tedesco, italiano e ladino secondo l'appartenenza dei residenti. Sono i due assi di disuguaglianza più caratteristici del territorio. ↑

711. ↑

712. Profilo territoriale: da un lato i centri urbani di Trento, Bolzano e Merano, che concentrano popolazione e servizi; dall'altro le numerose valli alpine a popolazione dispersa, dove le distanze e l'orografia rendono più oneroso il raggiungimento dei servizi. A questo asse territoriale si sovrappone, in Alto Adige, quello linguistico, poiché l'offerta deve essere garantita in tedesco, italiano e ladino secondo l'appartenenza dei residenti. Sono i due assi di disuguaglianza più caratteristici del territorio. Definizione: lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Nel Trentino-Alto Adige tale funzione è già esercitata in forme diverse dalle due Province autonome — il modello trentino di convenzione con studi privati e il Servizio psicologico territoriale dell'Alto Adige — e si tratta di strutturarla in un modello pieno e di armonizzarla fra i due ordinamenti provinciali, nel rispetto della rispettiva autonomia e del plurilinguismo. ↑

713. ↑

714. Profilo territoriale: da un lato i centri urbani di Trento, Bolzano e Merano, che concentrano popolazione e servizi; dall'altro le numerose valli alpine a popolazione dispersa, dove le distanze e l'orografia rendono più oneroso il raggiungimento dei servizi. A questo asse territoriale si sovrappone, in Alto Adige, quello linguistico, poiché l'offerta deve essere garantita in tedesco, italiano e ladino secondo l'appartenenza dei residenti. Sono i due assi di disuguaglianza più caratteristici del territorio. Definizione: lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Nel Trentino-Alto Adige tale funzione è già esercitata in forme diverse dalle due Province autonome — il modello trentino di convenzione con studi privati e il Servizio psicologico territoriale dell'Alto Adige — e si tratta di strutturarla in un modello pieno e di armonizzarla fra i due ordinamenti provinciali, nel rispetto della rispettiva autonomia e del plurilinguismo. Impianto della valutazione economica: lo studio impiega congiuntamente l'analisi costo-utilità, che rapporta il costo agli anni di vita ponderati per la qualità; l'analisi di impatto sul bilancio, che misura la sostenibilità finanziaria esercizio per esercizio; e l'analisi del ritorno sociale, che valuta il valore generato per la collettività. La doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società distingue rigorosamente i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali più ampie.

↑

715. Costo del servizio: assumendo un costo medio annuo per psicologo dell'ordine di 60.000 euro, comprensivo degli oneri, i tre scenari di copertura corrispondono a un costo annuo a regime dell'ordine di 7 milioni di euro nello scenario conservativo (circa 120 psicologi), 11 milioni nello scenario di base (circa 180) e 14 milioni nello scenario espansivo (circa 240). Il riferimento di 60.000 euro è più elevato che nelle altre regioni della serie, poiché il livello retributivo nel Trentino-Alto Adige è fra i più alti del Paese; i costi vanno letti come stima di base. ↑

716. Scenari di copertura del fabbisogno: lo scenario conservativo, di base ed espansivo rappresentano gradi crescenti di copertura della popolazione con disagio comune, verso la copertura piena del fabbisogno. Gli assetti attuali delle due Province, in forme parziali e non armonizzate, sono inferiori allo stesso scenario conservativo; gli scenari qui considerati rappresentano il modello pieno a copertura sistematica in entrambe le Province, e non le forme iniziali esistenti. ↑

717. Risparmio diretto sugli accessi impropri al pronto soccorso: dell'ordine di 1, 1 e 2 milioni di euro l'anno nei tre scenari, per effetto della riduzione degli accessi per cause psichiatriche e somatoformi intercettabili a livello territoriale, resi più onerosi dalle distanze nelle valli alpine; il margine è contenuto da un sistema di cure primarie già ben dotato. ↑

718. Risparmio diretto sulla spesa farmaceutica: dell'ordine di 1, 2 e 2 milioni di euro l'anno, per effetto della riduzione delle prescrizioni inappropriate di antidepressivi e ansiolitici nei quadri lievi, in favore dell'intervento psicologico; il margine è di entità ordinaria, in un sistema farmaceutico già governato. ↑

719. Risparmio diretto su ricoveri e specialistica: dell'ordine di 2, 3 e 5 milioni di euro l'anno, per effetto della riduzione di ricoveri evitabili, consultazioni specialistiche ripetute e accertamenti inappropriate connessi a disagio non riconosciuto; il margine di recupero è qui più contenuto che altrove, poiché il sistema è già ampiamente dotato ed efficiente e lascia meno consumo improprio da recuperare. ↑

720. Recupero della mobilità sanitaria: per il Trentino-Alto Adige il contributo è trascurabile, dell'ordine di 0, 1 e 1 milione di euro l'anno nei tre scenari. Il saldo di mobilità è modesto e per alcune branche attivo, poiché le due Province, per dotazione e qualità dei servizi, attraggono pazienti più di quanti ne perdano; questo canale contribuisce perciò solo marginalmente, a differenza delle regioni a forte saldo passivo. ↑

721. ↑

722. Recupero della mobilità sanitaria: per il Trentino-Alto Adige il contributo è trascurabile, dell'ordine di 0, 1 e 1 milione di euro l'anno nei tre scenari. Il saldo di mobilità è modesto e per alcune branche attivo, poiché le due Province, per dotazione e qualità dei servizi, attraggono pazienti più di quanti ne perdano; questo canale contribuisce perciò solo marginalmente, a differenza delle regioni a forte saldo passivo. Finalità del monitoraggio e della valutazione ex post: rendere conto dell'impiego delle risorse, apprendere dall'esperienza e correggere il corso dell'attuazione; la valutazione non è un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l'istituzione del servizio si traduce in apprendimento istituzionale, ed è ancorata a una clausola valutativa. ↑
723. Impianto secondo i tre livelli di struttura, processo ed esito: la valutazione distingue le condizioni e le risorse del servizio (struttura), le attività e il loro svolgimento (processo) e i risultati conseguiti (esito), in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti. ↑
724. Disegno controfattuale sulla strutturazione progressiva: poiché nel Trentino-Alto Adige la strutturazione del modello pieno avverrà in tempi differenziati fra i comprensori e i distretti delle due Province, la valutazione d'impatto può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione fra i territori sono impiegati a fini valutativi; gli assetti già operanti offrono una linea di base più ricca di quella delle regioni che partono da zero, utile a calibrare le stime. ↑
725. Linea di base dalla progressione differenziata: il diverso grado di strutturazione del modello pieno fra i comprensori delle due Province consente di costruire termini di confronto interni; la rilevazione, impostata in forma uniforme e interoperabile fra i due sistemi provinciali, fonda una stima dell'effetto su dati propri, valorizzando quelli già disponibili dal modello trentino e dal Servizio dell'Alto Adige. ↑
726. Metodi di stima dell'effetto: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze, che confronta l'evoluzione dei comprensori dove il modello pieno è già strutturato con quella dei comprensori non ancora raggiunti, e con il metodo del controllo sintetico, che costruisce un termine di confronto a partire dai dati osservati; la progressione differenziata della strutturazione fra i comprensori delle due Province fornisce la variazione necessaria all'identificazione. ↑
727. Indicatori di struttura: numero di sedi attivate nelle Case della Comunità, incarichi conferiti, ore di servizio disponibili, dotazione tecnologica e copertura territoriale rispetto al fabbisogno; misurano la capacità effettivamente installata. ↑
728. Indicatori di processo: prese in carico, tempo di attesa al primo colloquio, numero di colloqui per persona, tasso di invio appropriato ai servizi specialistici e aderenza ai percorsi clinici; misurano il funzionamento del servizio. ↑
729. Indicatori di esito clinico: quota di miglioramento e tasso di recupero, misurati con gli strumenti validati nei soli punteggi complessivi, e remissione dei quadri trattati; misurano il beneficio diretto per le persone. ↑
730. Indicatori di esito di sistema: accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche, prescrizioni di psicofarmaci nei quadri lievi, ricoveri evitabili e consultazioni specialistici impropri; misurano l'effetto dell'intervento sul resto del sistema. ↑
731. Indicatori economici: costo del servizio, risparmi diretti per canale, ricadute economico-sociali e rapporto beneficio-costi, calcolati su dati reali man mano disponibili; consentono di verificare ex post le stime dello studio e di sostituire progressivamente i valori ricostruiti con quelli effettivi. ↑
732. Indicatori di equità: copertura e accesso disaggregati per area — centro e periferie napoletane, province interne di Avellino e Benevento — e per fasce di età, con attenzione al disagio giovanile particolarmente rilevante in una regione giovane; verificano che il servizio riduca i divari anziché accrescerli, coerentemente con l'allocazione pro-equità raccomandata. ↑

733. Indicatori di qualità: soddisfazione degli utenti, appropriatezza delle prese in carico e degli invii, continuità del rapporto e qualità percepita della relazione; integrano la misurazione degli esiti con la dimensione dell'esperienza. ↑
734. Indicatori di mobilità: per il Trentino-Alto Adige sono monitorati ma costituiscono un esito atteso trascurabile, poiché le due Province attraggono pazienti più di quanti ne perdano e la mobilità non riguarda la domanda psicologica territoriale; la loro rilevazione serve a documentare un effetto marginale, non un effetto principale. ↑
735. Batteria complessiva di indicatori: l'insieme è organizzato in otto categorie — struttura, processo, esito clinico, esito di sistema, economici, equità, qualità e mobilità — per un totale dell'ordine di cinquantotto indicatori, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile della rilevazione; la batteria è comune alla serie e adattata al contesto sardo. ↑
736. Cruscotto di monitoraggio: gli indicatori confluiscono in un cruscotto aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; la titolarità del cruscotto è condivisa fra le due Province autonome, l'APSS e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (Sabes), che ne assicurano l'alimentazione comparabile e interoperabile fra i due sistemi. ↑
737. Clausola valutativa: lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa; il compito è corredare la strutturazione del modello pieno di clausole valutative, nei rispettivi ordinamenti provinciali, che impegnino le Giunte a riferire periodicamente ai Consigli provinciali sull'attuazione e sui risultati, traendo dagli assetti già operanti la base informativa e assicurando la comparabilità fra le due Province. ↑
738. Flusso informativo: la raccolta dei dati di processo e di esito poggia sui sistemi informativi delle due aziende sanitarie provinciali; il flusso va impostato in forma comparabile, completa e interoperabile fra i due sistemi, valorizzando i dati già disponibili dal modello trentino e dal Servizio dell'Alto Adige e assicurando l'uniformità della rilevazione fra le due Province. ↑
739. Tempi della valutazione: la valutazione si articola in un monitoraggio in itinere, che accompagna la strutturazione progressiva del servizio e ne osserva la diversa progressione fra i comprensori delle due Province; e in una valutazione ex post, che misura l'effetto a regime e ne verifica la sostenibilità; gli assetti già operanti consentono di disporre di una base informativa più ricca di quella delle regioni che partono da zero. ↑
740. Sintesi del monitoraggio: la valutazione è la condizione per trasformare la strutturazione del servizio in apprendimento, e il Trentino-Alto Adige può fondarla su dati operativi reali già disponibili dagli assetti delle due Province; perché ciò si realizzi, occorre corredare la strutturazione di clausole valutative nei rispettivi ordinamenti provinciali e consolidare un flusso informativo comparabile e interoperabile fra le due Province, valorizzando l'esperienza già maturata. ↑
741. Ricadute economico-sociali per la collettività: dell'ordine di 25, 48 e 67 milioni di euro l'anno nei tre scenari, comprensive del recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo — con peso particolare in un'economia ad alta attività, a pieno impiego e con redditi e produttività fra i più alti d'Europa, e nella componente giovanile, prevalente in una delle regioni più giovani d'Italia — oltre al valore del benessere recuperato e al minor carico assistenziale sulle famiglie; sono stimate con criteri conservativi. ↑
742. Ritorno complessivo annuo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali: dell'ordine di 29, 55 e 77 milioni di euro nei tre scenari. Detratto il costo del servizio, il saldo complessivo per la collettività è ampiamente positivo, dell'ordine di +22, +44 e +63 milioni di euro l'anno. ↑

743. Rapporto beneficio-costo complessivo: dell'ordine di 4,1 a uno nello scenario conservativo, 5,0 a uno in quello di base e 5,5 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale di 3,8-5,5 a uno adottata dallo studio e coerente con le stime metodologicamente fondate della letteratura. ↑
744. Distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico: è il punto che lo studio tiene fermo per il Trentino-Alto Adige e che ne governa la lettura. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di disavanzo, più ampio che nelle regioni sotto-finanziate perché il sistema, già ben dotato, lascia minori margini di recupero e il canale della mobilità è trascurabile; tale disavanzo resta tuttavia modesto e agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo di bilancio. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il solo ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe. La decisione va assunta riconoscendo che si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto e pienamente compatibile con la solidità finanziaria del territorio. ↑
745. Tabella economica consolidata: riepiloga, per i tre scenari, il costo del servizio, i risparmi diretti per canale, il saldo diretto, le ricadute sociali, il ritorno complessivo, il saldo complessivo e il rapporto beneficio-costi; è lo strumento sintetico per la decisione e distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale. ↑
746. Analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni, sconto del 3%): il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 euro del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: meno costoso e più efficace. Il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. ↑
747. Analisi di sensibilità probabilistica (diecimila simulazioni): l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, e dominante nell'84,6%; il beneficio monetario netto medio per paziente è dell'ordine di 7.815 euro, con un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. La robustezza del risultato clinico-economico per paziente è elevata, distintamente dall'incertezza sulle grandezze aggregate di sistema. ↑
748. Impatto sul bilancio e sostenibilità: il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta della spesa sanitaria, dell'ordine dello 0,3% nello scenario conservativo e dello 0,5% in quello espansivo. La sostenibilità è qui il punto più favorevole della serie: entrambe le Province autonome finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto, senza apporto a carico dello Stato, e operano in avanzo, con la spesa pro-capite più alta d'Italia. Il vincolo non è la scarsità di risorse: la strutturazione del modello pieno è agevolmente finanziabile entro l'autonomia di bilancio di ciascuna Provincia, e la questione è di scelta allocativa e di coordinamento, non di copertura. ↑
749. Lacuna dei dati e sua mitigazione: le grandezze economiche sono allo stato in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione (1,8%) e non estratte dai conti certificati delle due aziende sanitarie provinciali; il Trentino-Alto Adige dispone tuttavia, grazie agli assetti già operanti, di una base di dati propri più solida di quella delle regioni che partono da zero, sicché la stima, fondata sui benchmark internazionali, può essere affinata con i dati del modello trentino e del Servizio dell'Alto Adige. L'estrazione dei dati certificati delle due Province resta la priorità da completare prima della presentazione esterna. ↑
750. Sintesi della valutazione economica: il caso diretto è prudente e in disavanzo modesto per il bilancio sanitario, agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo; il caso sociale è robusto e fortemente positivo; il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità. La coerenza con la cautela metodologica già enunciata — i risparmi sanitari diretti non sono certi sul piano statistico — è piena: il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali, non in un risparmio di bilancio che lo studio si astiene dal rivendicare. ↑

751. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 217.000 persone con disagio comune, in parte già raggiunto dagli assetti esistenti delle due Province ma non ancora coperto in un modello pieno; poiché il servizio è presente in forme diverse e non armonizzate, l'intervento va strutturato e dimensionato verso il fabbisogno a regime in entrambe le Province autonome. ↑
752. Modello organizzativo: lo psicologo delle cure primarie opera nelle Case della Comunità e nei distretti sanitari, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i servizi di salute mentale. Il punto di partenza è dato dai due assetti provinciali esistenti: in Trentino il modello di convenzione fra l'APSS e studi psicologici privati (legge provinciale del 2016), che eroga cicli di sedute in sei ambiti su invio dell'Azienda e con ticket; in Alto Adige il Servizio psicologico territoriale pubblico, organizzato per comprensori sanitari e bilingue. La strutturazione in un modello pieno di psicologo di base e l'armonizzazione fra i due assetti — in un territorio ripartito in due Province autonome con Servizi sanitari distinti, e con l'esigenza di erogare il servizio in tedesco, italiano e ladino — sono la sfida organizzativa principale, da affrontare nel rispetto dell'autonomia di ciascuna Provincia. ↑
753. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
754. Percorso clinico: accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista; valutazione iniziale e progetto clinico individuale; ciclo di colloqui brevi e programma di sostegno personalizzato; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. Il percorso, da strutturare in forma piena e armonizzata fra le due Province a partire dagli assetti già operanti, alle restanti, affronta i quadri più frequenti — sintomatologia ansioso-depressiva, problemi di adattamento, fasi del ciclo di vita, disagi emotivi transitori, problematiche psicosomatiche. ↑
755. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
756. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
757. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
758. ↑
759. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). Funzione della sintesi: la parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo, impiegando l'analisi multi-criterio per integrare in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie; non somma grandezze disomogenee, ma le pondera secondo criteri espliciti, rendendo verificabile il passaggio dall'evidenza alla raccomandazione. ↑
760. Sintesi per dominio: il bisogno è ampio in un territorio fra i più giovani d'Italia, con il disagio giovanile in primo piano e la dimensione plurilingue; l'efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida, affinata dai dati propri degli assetti già operanti; il quadro economico distingue un caso finanziario di disavanzo modesto, agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo, da un caso sociale fortemente positivo; l'equità è favorevole sull'asse territoriale e su quello linguistico e sulla dimensione generazionale, ed è

rafforzata dall'armonizzazione fra le due Province; la fattibilità è quella della strutturazione di assetti già operanti, agevolata dalla piena autonomia finanziaria; il monitoraggio può fondarsi su una base informativa più ricca che altrove. La convergenza dei domini sostiene una raccomandazione favorevole. ↑

761. Metodo dell'analisi multi-criterio: i criteri di valutazione sono otto, ciascuno con un peso esplicito — efficacia clinica, costo-efficacia e ritorno economico, impatto sul bilancio e sostenibilità, equità, valore sociale, fattibilità, robustezza dell'evidenza e coerenza strategica — e l'intervento è confrontato con l'alternativa del non intervento attribuendo a ciascuno un punteggio, la cui media ponderata fornisce il giudizio complessivo. ↑
762. Criteri e pesi adottati: efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno economico 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell'evidenza 10%, coerenza strategica 5%; la struttura dei pesi è comune a tutti gli studi della serie, a garanzia di confrontabilità. ↑
763. Punteggio dell'intervento: la media ponderata dei punteggi attribuiti all'intervento è dell'ordine di 81,0 su 100, la più elevata della serie, sostenuta dal punteggio molto alto nell'impatto sul bilancio e nella sostenibilità — che riflette la piena autonomia finanziaria e l'avanzo di bilancio delle due Province — e dai punteggi elevati nel valore sociale, nella costo-efficacia e nella coerenza strategica, e contenuta dal punteggio più basso nella robustezza dell'evidenza. ↑
764. Punteggio del non intervento: l'alternativa di non portare il servizio a regime ottiene una media ponderata dell'ordine di 39,2 su 100; essa è penalizzata in tutti i criteri sostanziali — efficacia, equità, valore sociale, ritorno — e è sostenuta soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, che però nel Trentino-Alto Adige appare oggi poco giustificata, poiché lascerebbe non strutturati e non armonizzati assetti già operanti in entrambe le Province. ↑
765. Interpretazione del confronto: l'intervento prevale nettamente sul non intervento, con uno scarto dell'ordine di quarantadue punti; il punteggio dell'intervento si colloca al primo posto fra le regioni esaminate, riflettendo la piena autonomia finanziaria, l'avanzo di bilancio e gli assetti già operanti, pur scontando un caso finanziario diretto in disavanzo modesto, peraltro agevolmente sostenibile. ↑
766. Robustezza della raccomandazione: la prevalenza dell'intervento si mantiene anche facendo variare i pesi dei criteri entro intervalli ragionevoli; nessuna combinazione plausibile dei pesi rovescia il giudizio, sicché la raccomandazione è robusta rispetto alle scelte valoriali sottostanti alla ponderazione. ↑
767. Raccomandazione principale: si raccomanda di strutturare in un modello pieno di psicologo di base gli assetti già operanti nelle due Province — il modello trentino di convenzione e il Servizio psicologico dell'Alto Adige — armonizzandoli fra i due ordinamenti provinciali e dimensionandolo verso la copertura piena del fabbisogno; è la decisione che il Trentino-Alto Adige, dotato di assetti già operanti e di piena autonomia finanziaria, è chiamato a compiere per dare al servizio una forma compiuta e omogenea. ↑
768. Dimensionamento raccomandato: si raccomanda di muovere dagli assetti già operanti nelle due Province e di procedere per gradi verso lo scenario conservativo, dell'ordine di 120 psicologi, quindi verso quello di base, dell'ordine di 180, e infine verso quello espansivo, dell'ordine di 240, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità. ↑
769. Condizioni della raccomandazione: la costruzione di clausole valutative a corredo della strutturazione, nei rispettivi ordinamenti provinciali, l'adozione di un'allocazione pro-equità verso le valli alpine, i gruppi linguistici e il disagio giovanile, una sede di coordinamento fra le due Province e l'impostazione di un flusso informativo comparabile e interoperabile fra i due sistemi sono le condizioni che trasformano la raccomandazione in un'attuazione efficace e valutabile. ↑

770. Lacuna da colmare prima della presentazione esterna: l'estrazione dei conti certificati delle due aziende sanitarie provinciali e il consolidamento di un flusso comparabile dei dati di esito fra le due Province sono le priorità che consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive. ↑
771. Distinzione cardine ribadita: la decisione va assunta riconoscendo che il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, mentre il caso economico complessivo, comprensivo delle ricadute sociali, è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto per il bilancio, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto. ↑
772. Collocazione nella serie regionale: lo studio sul Trentino-Alto Adige è il dodicesimo della serie, dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, il Trentino-Alto Adige occupa una posizione propria e unica, quella del territorio ripartito in due Province autonome con Servizi sanitari distinti, fra i più giovani, ricchi e sani d'Italia, a piena autonomia finanziaria e in avanzo di bilancio, che dispone già di assetti di psicologia territoriale in entrambe le Province — il modello trentino di convenzione e il Servizio psicologico dell'Alto Adige — e che oggi è chiamato a strutturarli in un modello pieno e ad armonizzarli fra i due ordinamenti provinciali. ↑
773. Avvertenza conclusiva sulle semplificazioni: lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico — il rapporto di quattro a uno, il moltiplicatore per dieci, il rapporto di due e mezzo a uno — e adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, coerente con le stime metodologicamente fondate; è una scelta di credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica. ↑
774. Conclusione: la decisione che lo studio sostiene è di strutturare in un modello pieno di psicologia di base gli assetti già operanti nelle due Province, armonizzandoli fra i due ordinamenti provinciali, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno e corredandolo di clausole valutative; per il Trentino-Alto Adige, dotato di assetti già operanti, di piena autonomia finanziaria e di bilanci in avanzo, ciò significa dare al servizio una forma compiuta e omogenea, a beneficio della popolazione. ↑
775. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale. Poiché il servizio è presente in forme diverse, il flusso informativo va impostato in forma uniforme e interoperabile fra i sistemi delle due Province, valorizzando i dati già disponibili dal modello trentino e dal Servizio dell'Alto Adige prima della piena operatività; gli assetti già operanti nelle due Province forniscono un primo modello di rilevazione. ↑
776. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑
777. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
778. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
779. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: nel Trentino-Alto Adige sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle valli alpine a popolazione dispersa, dove le distanze e l'orografia rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; in un contesto plurilingue consentono inoltre di mettere a disposizione, anche a distanza, personale della lingua del paziente. Tali strumenti sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza, e assumono un rilievo particolare in una delle regioni più anziane d'Italia. ↑

780. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. [↑](#)
781. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso l'Università di Trento e la Libera Università di Bolzano); post-universitario specialistico (formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, comprensiva della competenza per il disagio giovanile, prioritario in una delle regioni più giovani d'Italia, e delle competenze linguistiche per l'erogazione in tedesco, italiano e ladino); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). Il Trentino-Alto Adige presenta qui un elemento di metodo: l'esperienza trentina di convenzione, attiva dal 2016, e il Servizio psicologico dell'Alto Adige costituiscono una base operativa su cui innestare il percorso formativo del modello pieno. [↑](#)
782. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. [↑](#)
783. [↑](#)
784. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. Ruolo della modellazione: poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l'orizzonte direttamente osservabile, lo studio proietta costi ed esiti nel tempo mediante un modello decisionale, e ne governa l'incertezza con tecniche deterministiche e probabilistiche; la modellazione non genera certezze, ma rende esplicite e verificabili le assunzioni. [↑](#)
785. Struttura del modello di Markov: la storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%; il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. [↑](#)
786. Parametri principali del modello: a ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita; il costo per ciclo è dell'ordine di 40 euro per lo stato di recupero e di 700 euro per la cronicità, con l'intervento che comporta un costo una tantum dell'ordine di 300 euro; le grandezze sono trattate come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l'incertezza. [↑](#)
787. Esito del caso base: l'intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell'ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità rispetto al comparatore; il risultato è robusto rispetto alle variazioni dei singoli parametri entro intervalli plausibili. [↑](#)
788. Analisi di sensibilità deterministica a un parametro per volta: la variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — entro intervalli plausibili non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. [↑](#)
789. [↑](#)
790. Analisi di sensibilità deterministica a un parametro per volta: la variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — entro intervalli plausibili non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudenziale per l'ottimismo delle stime. [↑](#)

791. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
792. Quadro economico consolidato per il Trentino-Alto Adige (Parte E): a regime, da circa 120 a circa 240 psicologi, costo del servizio di 7-14 milioni, risparmi diretti di 4-10 milioni, ricadute sociali di 25-67 milioni; il saldo diretto è negativo ma modesto e agevolmente sostenibile a fronte dell'avanzo, il saldo complessivo fortemente positivo, con rapporto beneficio-costi di 4,1-5,5 a uno, entro la banda prudenziale di 3,8-5,5 a uno adottata dalla serie. ↑
793. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
794. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio; nel Trentino-Alto Adige, poiché il servizio è presente in forme diverse nelle due Province, il flusso va impostato in forma comparabile e interoperabile fra i due sistemi provinciali, valorizzando i dati già disponibili, in forma uniforme e completa fra le due Province. ↑
795. Valori di ancoraggio per il Trentino-Alto Adige: popolazione di circa 1.085.000 abitanti (dati ISTAT 2024), pari a circa l'1,8% del totale nazionale, in crescita per natalità elevata e saldi migratori positivi, ripartita quasi equamente fra le due Province autonome di Trento e Bolzano; struttura per età fra le più giovani d'Italia, con speranza di vita fra le più alte; Alto Adige plurilingue (68,61% tedesco, 26,98% italiano, 4,41% ladino), Trentino italofono con minoranze ladine, mochene e cimbre, e componente straniera dell'ordine del 9-10%; due Servizi sanitari provinciali autonomi, che finanziano integralmente la sanità con i nove decimi del gettito trattenuto, senza apporto statale, e operano in avanzo, con la spesa pro-capite più alta d'Italia; saldo di mobilità modesto e per alcune branche attivo, poiché le Province attraggono pazienti, sicché il canale di recupero è trascurabile; fabbisogno a regime fino a circa 240 psicologi nello scenario espansivo. ↑
796. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione (1,8%), e non estratti dai conti provinciali certificati; i dati da acquisire presso le due aziende sanitarie provinciali sono elencati nella tabella seguente. Poiché il servizio è presente in forme diverse nelle due Province, il territorio dispone tuttavia, grazie agli assetti già operanti, di una base di dati propri più solida di quella delle regioni che partono da zero, da consolidare in forma comparabile fra le due Province. ↑
797. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑
798. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni agli studi pugliese, lombardo, veneto, emiliano-romagnolo, piemontese, toscano, ligure, laziale e campano, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑
799. Analisi di sensibilità probabilistica su diecimila simulazioni: l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. ↑
800. Curva di accettabilità: alla soglia convenzionale di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è prossima al 90%, e cresce ulteriormente per soglie superiori; già a soglie molto inferiori l'intervento mantiene un'elevata probabilità di convenienza. ↑

801. Analisi di scenario: i tre scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; gli assetti attuali delle due Province, in forme parziali e non armonizzate, corrispondono a un livello inferiore allo scenario conservativo, e costituiscono la prima tappa di un percorso di strutturazione progressiva del modello pieno e di armonizzazione fra le due Province verso la copertura sistematica. [↑](#)
802. Incertezza sulle grandezze aggregate: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce esplicitamente e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema. [↑](#)
803. Disegno della verifica empirica: poiché nel Trentino-Alto Adige la strutturazione del modello pieno avverrà in tempi differenziati fra i comprensori e i distretti delle due Province, la verifica controfattuale può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione fra i territori sono impiegati a fini valutativi. Gli assetti già operanti — il modello trentino di convenzione e il Servizio psicologico dell'Alto Adige — consentono di rilevare una linea di base più ricca di quella delle regioni che partono da zero, e l'attivazione scaglionata fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto. [↑](#)
804. Metodi della verifica empirica: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, a partire dai dati già disponibili dagli assetti esistenti e dalla progressione differenziata della strutturazione fra i comprensori delle due Province, che fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto. [↑](#)
805. Valore dell'informazione e priorità di ricerca: l'analisi del valore atteso dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione del Trentino-Alto Adige, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle due aziende sanitarie provinciali e l'impostazione di un flusso uniforme e interoperabile dei dati di esito fra le due Province, valorizzando i dati già disponibili dagli assetti esistenti. [↑](#)
806. [↑](#)
807. Posizione giuridica del Veneto: la Regione è stata l'apripista nazionale, avendo avviato già nel 2014, con deliberazione della Giunta, la prima sperimentazione di un servizio di psicologia di base nelle aziende sanitarie; con la mozione n. 302 del 2022 il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta ad avviare un Servizio permanente di psicologia delle cure primarie collegato alle Case di Comunità; sono in corso d'esame proposte di legge dedicate (n. 241/2023 e n. 321/2025), mentre non è ancora stata approvata una legge regionale specifica. La cornice organizzativa di riferimento è la legge regionale n. 19 del 2016, istitutiva dell'Azienda Zero e di riassetto delle Aziende ULSS. [↑](#)
808. Stato attuale: a differenza della Puglia, dove una legge regionale ha istituito e dotato un servizio specifico, e della Lombardia, dove la riforma sociosanitaria del 2021 ha previsto in forma generica la funzione psicologica territoriale, il Veneto dispone di una consolidata esperienza sperimentale e di un impegno politico formale, ma non ancora di una legge strutturale: la decisione rilevante è pertanto se strutturare e dimensionare il servizio permanente già impegnato, dandogli un modello operativo, un dimensionamento e una copertura. [↑](#)
809. Salute mentale in Veneto: la domanda è sospinta da tre componenti. La prima è il disagio connesso al lavoro nella popolazione attiva, particolarmente rilevante in un'economia dinamica a elevata occupazione e a diffusa imprenditoria di piccola e media dimensione. La seconda è il bisogno dell'età anziana, accentuato nel Polesine e nel Bellunese. La terza è il disagio giovanile: nel 2021 si sono registrati 3.413 nuovi casi di

disturbo mentale nella fascia 14-24 anni. A ciò si aggiunge un'erosione documentata degli organici dei Dipartimenti di Salute Mentale, con una riduzione dell'ordine del 10% degli psicologi e del 30% degli educatori professionali tra il 2022 e il 2024, e liste di attesa prolungate. ↑

810. Popolazione residente in Veneto 4.853.472 abitanti (Censimento permanente ISTAT 2024), pari a circa l'8,2% della popolazione nazionale, quarta-quinta regione italiana; età media 47,1 anni, lievemente superiore alla media nazionale; popolazione ultra-ottantacinquenne in crescita, oltre le duecentomila unità; sette province, con un modello insediativo diffuso e una marcata variabilità interna tra la pianura e le aree montane. ↑
811. Le quattro cornici metodologiche apicali adottate: il modello centrale dell'HTA di EUnetHTA (nove domini), oggi nella cornice del Regolamento UE 2021/2282 sull'Health Technology Assessment, applicabile dal gennaio 2025; il Five Case Model del Green Book del Tesoro del Regno Unito; lo standard CHEERS 2022 per il reporting delle valutazioni economiche; e i criteri di valutazione dell'OCSE-DAC. ↑
812. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; servizio attuale come comparatore. ↑
813. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute. Il modello incorpora una correzione prudenziale per la tendenza, documentata nella letteratura sulla valutazione degli investimenti pubblici, a sottostimare i costi e a sovrastimare i benefici. ↑
814. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. Per il Veneto, regione a saldo di mobilità attivo e dotata di un sistema sanitario di eccellenza, il canale del recupero della mobilità passiva non si applica e i margini di recupero diretto sono contenuti: il saldo diretto risulta lievemente negativo e il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi. ↑
815. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (8,2%) e non estratti dai conti regionali certificati: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare presso l'Azienda Zero e le Aziende ULSS prima della presentazione esterna. ↑
816. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
817. Valutazione controfattuale d'impatto: i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico; il dispiegamento scaglionato del servizio tra le nove Aziende ULSS, attivate in tempi diversi sotto il coordinamento dell'Azienda Zero, funge da esperimento naturale e consente di stimare l'effetto causale rendendo le aziende non ancora coperte gruppo di confronto. ↑
818. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione, Azienda Zero, Aziende ULSS e Ordine degli Psicologi del Veneto — nel quale l'Azienda Zero, ente di governo regionale con funzioni centralizzate di programmazione e acquisto, costituisce il veicolo per una progettazione unitaria e un'attuazione omogenea del servizio su tutte le nove aziende. ↑
819. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑

820. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
821. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. ↑
822. Popolazione residente in Veneto 4.853.472 abitanti (Censimento permanente ISTAT 2024), pari a circa l'8,2% del totale nazionale, quarta-quinta regione italiana; età media 47,1 anni; popolazione ultra-ottantacinquenne in crescita, oltre le duecentomila unità. ↑
823. Aspettativa di vita alla nascita dell'ordine degli 84 anni, tra le più elevate d'Italia, coerente con il profilo di un sistema sanitario di eccellenza e con buoni determinanti socio-economici. ↑
824. Componente straniera dell'ordine del 10% dei residenti, in funzione di parziale ringiovanimento della struttura per età, con implicazioni per l'accesso linguistico e culturale ai servizi. ↑
825. Articolazione del territorio in sette province: Padova e Verona, entrambe oltre i novecentomila abitanti; Treviso, Vicenza e Venezia; Rovigo e Belluno, le meno popolate; modello insediativo diffuso, con i quattro capoluoghi maggiori che raccolgono circa un sesto della popolazione. ↑
826. Profilo per età composito e a marcata variabilità interna: le province di Verona, Vicenza e Treviso presentano la struttura più giovane, mentre il Polesine e il Bellunese sono nettamente più anziani; il Bellunese è la provincia più anziana e l'unica a registrare un incremento della mortalità. ↑
827. Disagio psichico comune o sottosoglia stimato nell'ordine di 970.000 persone, ottenuto per proiezione dei tassi di prevalenza nazionali sulla popolazione veneta; è la quota di bisogno potenziale cui il servizio si rivolge in via prioritaria. ↑
828. Utenza specialistica in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale stimata nell'ordine di 72.000 persone; il dato è una proiezione da verificare sui flussi regionali certificati. ↑
829. Disagio giovanile: nel 2021 si sono registrati 3.413 nuovi casi di disturbo mentale nella fascia 14-24 anni; l'offerta dedicata è fortemente sottodimensionata, con appena dodici posti letto di neuropsichiatria infantile sull'intero territorio regionale. ↑
830. Salute mentale connessa al lavoro: in un'economia dinamica, a elevata occupazione e a diffusa imprenditoria di piccola e media dimensione, ampia parte dei lavoratori è esposta a fattori di stress correlati al lavoro; l'intercettazione precoce del disagio nella popolazione attiva ha un valore particolarmente elevato in termini di produttività recuperata. ↑
831. Bisogno dell'età anziana: la domanda connessa all'invecchiamento, alla cronicità e alla comorbidità psicologica delle patologie croniche è accentuata nel Polesine e nel Bellunese, aree più anziane e a maggiore difficoltà di accesso. ↑
832. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche stimati nell'ordine di 22.000-24.000 l'anno, per proiezione dai valori nazionali; una quota è riconducibile a disagio comune non intercettato a monte. ↑
833. Offerta territoriale strutturata: il Veneto dispone di un'esperienza sperimentale consolidata, avviata nel 2014, e di un impegno politico formale (mozione n. 302/2022) ad avviare un servizio permanente, ma non ancora di un servizio strutturato e dimensionato a regime. ↑
834. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 1.050 psicologi (intervallo 1.000-1.120). L'Ordine degli Psicologi del Veneto segnala una dotazione dell'ordine di cinque psicologi ogni centomila abitanti, a fronte di una media europea di venti e di un valore ottimale di quaranta. ↑

835. Copertura attuale del fabbisogno prossima a zero in termini di servizio dimensionato a regime; il quadro è aggravato da un'erosione recente degli organici dei Dipartimenti di Salute Mentale — dell'ordine del 10% degli psicologi e del 30% degli educatori professionali tra il 2022 e il 2024 — e da liste di attesa prolungate. ↑
836. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante in Veneto non è un gradiente di deprivazione né una frattura Nord-Sud, ma la dualità fra la pianura densamente popolata e produttiva e le aree montane del Bellunese e dell'Altopiano, anziane e in spopolamento, dove l'accesso ai servizi è più difficoltoso; la telepsicologia assistita è lo strumento per ridurlo. ↑
837. Finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 11 miliardi di euro (Fondo Sanitario Regionale indistinto 2026 stimato in 11,14 miliardi; spesa corrente per i LEA 11,76 miliardi); conti in equilibrio, con presa d'atto della condizione di equilibrio economico-finanziario prospettico (DGR 205/2025); nessun piano di rientro. ↑
838. Mobilità sanitaria a saldo attivo dell'ordine di +198 milioni di euro (2022, Fondazione GIMBE): crediti per 506,7 milioni e debiti per 308,5 milioni; il Veneto è terza regione d'Italia per saldo attivo dopo Emilia-Romagna e Lombardia, con un indice di fuga del 10,43%. Essendo la regione creditrice, il canale del recupero della mobilità passiva non si applica. ↑
839. Servizi e flussi: nove Aziende ULSS di grandi dimensioni, l'Azienda Zero quale ente di governo regionale, due Aziende Ospedaliere universitarie (Padova e Verona) e l'Istituto Oncologico Veneto; rete delle Case di Comunità in costruzione nell'ambito del PNRR; accessi al pronto soccorso dell'ordine di 1,5 milioni l'anno. ↑
840. Cornice normativa e programmatica: la sperimentazione regionale avviata nel 2014; la mozione consiliare n. 302/2022; le proposte di legge n. 241/2023 e n. 321/2025 in corso d'esame; la legge regionale n. 19/2016 (Azienda Zero); la legge regionale n. 9/2024 sui servizi sociali; il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale; in assenza, allo stato, di una legge nazionale che disciplini la figura. ↑
841. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Dipartimenti di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. ↑
842. Teoria del cambiamento: la catena logica collega il bisogno (disagio comune diffuso e non intercettato) all'attività (presa in carico psicologica di prossimità), agli esiti clinici (recupero dei quadri lievi-moderati), di sistema (riduzione di accessi impropri, prescrizioni inappropriate e liste di attesa) e sociali (recupero di produttività e di funzionamento), per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria. ↑
843. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 970.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato dall'offerta strutturata attuale. ↑
844. Modello organizzativo: lo psicologo di base opera nelle Case di Comunità e nelle medicine di gruppo integrate, in collaborazione con i medici di medicina generale, secondo protocolli condivisi; l'Azienda Zero coordina la progettazione unitaria e l'attuazione omogenea sulle nove Aziende ULSS, con economie di scala. ↑
845. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
846. Percorso clinico: accesso diretto o su segnalazione del medico di medicina generale; valutazione iniziale; ciclo di colloqui brevi; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. ↑

847. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
848. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
849. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
850. Sistema informativo e interoperabilità: la registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con il fascicolo sanitario elettronico regionale, consente il monitoraggio continuo e la valutazione; l'Azienda Zero, titolare di funzioni informative centralizzate, ne è il riferimento naturale. ↑
851. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale, e va prevista fin dall'avvio del servizio. ↑
852. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑
853. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
854. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
855. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: nel Veneto sono lo strumento decisivo per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle aree montane del Bellunese e dell'Altopiano, anziane e in spopolamento; sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza. ↑
856. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
857. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso le Università di Padova e Verona); post-universitario specialistico (corso regionale con attestato sulla psicologia di base e le cure primarie); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). ↑
858. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La centralizzazione delle funzioni di acquisto e formazione in capo all'Azienda Zero, unita alla solidità organizzativa del sistema, candida il Veneto a contesto esemplare a livello nazionale per l'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale. ↑
859. Metodo della revisione: la sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche (PRISMA 2020) e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE; sono considerati studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. ↑
860. Studio fondativo del modello collaborativo (IMPACT), pubblicato su JAMA nel 2002: circa il 50% dei pazienti trattati ha conseguito una riduzione di almeno il 50% dei sintomi a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. ↑
861. Meta-analisi su cinquantasette studi controllati (2012): l'integrazione della cura ha prodotto un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard rispetto alla cura usuale. ↑

862. Revisione di quarantadue implementazioni del modello (2024): riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 43% dell'ansia a sei mesi, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. [↑](#)
863. Programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies), dati reali 2023-2024: tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile del 67,8% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su una scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno. [↑](#)
864. Meta-analisi sulle cure integrate: coefficiente standardizzato dell'ordine di $-0,11$ sui sintomi depressivi, di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante quando applicato a una popolazione ampia. [↑](#)
865. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. [↑](#)
866. Cautela metodologica rilevante: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi (l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero); il valore economico del modello poggia in misura preponderante sui ritorni sociali, non sui risparmi sanitari diretti. Questa cautela è coerente con il profilo del caso economico veneto. [↑](#)
867. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. [↑](#)
868. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. [↑](#)
869. Benchmark australiano (Better Access): modello a invio esterno che ha innalzato la quota di popolazione in trattamento dal 35% al 46%, con elevata soddisfazione degli utenti. [↑](#)
870. Benchmark statunitense (Collaborative Care): modello a équipe integrata, validato da oltre novanta studi controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri. [↑](#)
871. Esperienze italiane: le sperimentazioni locali, fra cui quelle riconducibili al modello di Solano nel Lazio, anticipano l'integrazione psicologica nelle cure primarie; i dati derivano però da campioni limitati e in parte da letteratura grigia, e vanno assunti con la dovuta cautela. [↑](#)
872. Trasferibilità: i risultati internazionali provengono da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale; la loro trasposizione richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche. [↑](#)
873. Evidenza locale veneta: il Veneto è stato l'apripista nazionale, avendo avviato già nel 2014 una sperimentazione regionale di psicologia di base; questa esperienza costituisce una base di evidenza locale di particolare valore, da analizzare e valorizzare sistematicamente nel disegno del servizio permanente. [↑](#)
874. Condizioni venete favorevoli alla trasferibilità: la solidità organizzativa del sistema, l'architettura centralizzata dell'Azienda Zero e l'esperienza sperimentale pregressa costituiscono un terreno favorevole all'adozione del modello e alla sua valutazione rigorosa. [↑](#)
875. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative: il rapporto di 4:1 spesso citato e l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio sono semplificazioni a fini divulgativi. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8:1-5,6:1. [↑](#)

876. Identificazione dei costi: il costo del servizio comprende le remunerazioni dei psicologi, i costi organizzativi e di coordinamento e la quota destinata alla formazione congiunta; è stimato per scenario di copertura ed espresso a regime. ↑
877. Costo del servizio per scenario, a regime: dell'ordine di 30 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 45 nello scenario base e 58 nello scenario espansivo, coerente con il valore di circa 55-57 milioni indicato per la piena copertura quando si include il programma di formazione all'intelligenza artificiale. ↑
878. Metodo di stima del costo: il valore unitario per incarico è dell'ordine di 55.000 euro annui; la stima è regionalizzata in proporzione alla popolazione e al numero di professionisti, con economie di scala consentite dalla centralizzazione delle funzioni di acquisto in capo all'Azienda Zero. ↑
879. Identificazione e misura degli esiti: gli esiti di salute sono espressi in anni di vita ponderati per la qualità e in esiti clinici validati; i tassi di recupero e di miglioramento sono desunti dai benchmark consolidati e applicati in via prudenziale. ↑
880. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi (questionario a nove voci sui sintomi depressivi e scala a sette voci per il disturbo d'ansia); tasso di recupero di riferimento dell'ordine del 50%. ↑
881. Costo-efficacia e costo-utilità: il costo per anno di vita ponderato per la qualità si colloca al di sotto della soglia comunemente adottata; l'analisi per paziente, sviluppata nella Parte F, indica condizioni di dominanza dell'intervento rispetto all'opzione di non intervento. ↑
882. Soglia di costo-efficacia di riferimento dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, coerente con la prassi internazionale della valutazione economica in sanità. ↑
883. Impatto sul bilancio: i risparmi diretti per il Servizio sanitario regionale si articolano nei canali del pronto soccorso, della farmaceutica e dei ricoveri e prestazioni specialistiche evitabili; il canale della mobilità recuperata è nullo, poiché il Veneto è regione a saldo di mobilità attivo. ↑
884. Risparmi diretti complessivi per il Servizio sanitario regionale stimati nell'ordine di 18 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 30 nello scenario base e 45 nello scenario espansivo, collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa dell'intervallo in ragione dell'elevata efficienza del sistema. ↑
885. Saldo diretto per il bilancio sanitario, dato dalla differenza tra risparmi diretti e costo del servizio, dell'ordine di -12, -15 e -13 milioni di euro annui nei tre scenari: è lievemente negativo, coerentemente con la natura di regione creditrice e con l'elevata appropriatezza del sistema veneto. ↑
886. Il saldo diretto negativo è dichiarato senza attenuazioni e non costituisce una debolezza dell'analisi, ma il suo profilo onesto: a differenza della Puglia, dove il recupero della mobilità passiva concorre al pareggio diretto, in Veneto il valore dell'intervento risiede in misura preponderante nelle ricadute economico-sociali, ed è questa la chiave di lettura del caso economico. ↑
887. Ritorno sociale: le ricadute economico-sociali comprendono il valore della maggiore produttività recuperata, la riduzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, le efficienze nel sistema dei servizi di salute mentale e il sollievo alle figure di cura familiari. In un'economia dinamica e a elevata occupazione, la componente della produttività recuperata è la voce di maggior peso del beneficio complessivo. ↑
888. Ricadute economico-sociali stimate nell'ordine di 95 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 180 nello scenario base e 280 nello scenario espansivo, secondo i metodi del ritorno sociale sull'investimento, con criteri di stima conservativi. ↑
889. Ritorno complessivo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali, dell'ordine di 113, 210 e 325 milioni di euro annui nei tre scenari; il saldo complessivo, al netto del costo del servizio, è dell'ordine di +83, +165 e +267 milioni di euro annui. ↑

890. Rapporto beneficio-costo complessivo dell'ordine di 3,8:1 nello scenario conservativo, 4,7:1 nello scenario base e 5,6:1 nello scenario espansivo, in linea con il valore validato sulle altre regioni e coerente con le stime metodologicamente fondate della letteratura. [↑](#)
891. Caso economico e caso finanziario secondo il Five Case Model: il caso finanziario, riferito al solo bilancio sanitario, presenta un saldo diretto lievemente negativo; il caso economico, riferito alla collettività, è ampiamente positivo. La distinzione tra le due grandezze è la chiave dell'analisi. [↑](#)
892. Sostenibilità finanziaria: il costo del servizio si colloca nell'ordine dello 0,3-0,5% di un Fondo Sanitario Regionale di circa 11 miliardi di euro, importo pienamente sostenibile per un sistema solido e in equilibrio, e ulteriormente ottimizzabile grazie alle economie di scala consentite dall'Azienda Zero. [↑](#)
893. Lacuna prioritaria: le grandezze economiche qui impiegate sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione (8,2%) e non estratte dai conti regionali certificati; la loro verifica presso l'Azienda Zero e le Aziende ULSS è condizione per la presentazione alle autorità di finanza pubblica. [↑](#)
894. Questa parte sviluppa i metodi di modellazione e di gestione dell'incertezza del quinto dominio, secondo le buone pratiche di ricerca sulla modellazione dell'ISPOR e dell'Accademia delle scienze, ed è riportata secondo lo standard CHEERS 2022. [↑](#)
895. Modello di Markov a coorte, strumento standard della valutazione economica in sanità: rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi (sintomatico, recupero, cronico, morte), scanditi da cicli con correzione di metà ciclo; la microsimulazione ne costituisce la variante per le traiettorie individuali. [↑](#)
896. Risultati del caso base (singolo paziente, orizzonte di cinque anni, valori scontati): il braccio dell'intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un'utilità di 3,627 anni di vita ponderati, contro un costo di circa 3.799 euro e un'utilità di 3,392 dell'assistenza usuale; l'intervento è quindi meno costoso (di circa 1.304 euro) e più efficace (di circa 0,236 anni), configurando una dominanza. [↑](#)
897. La dominanza si spiega con la struttura del modello: a fronte di un costo iniziale contenuto, l'intervento accresce il tempo trascorso nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce il tempo trascorso nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte. Il risultato per paziente è il fondamento microeconomico delle stime aggregate della Parte E ed è indipendente dalla regione. [↑](#)
898. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. [↑](#)
899. Distribuzioni e fonti: distribuzioni Beta per le probabilità di transizione e per le utilità, vincolate all'intervallo tra zero e uno, e distribuzioni Gamma per i costi, vincolati ai valori positivi; valori centrali e intervalli tratti dall'evidenza internazionale (Parte D) e da calibrare, per i parametri regionali, sui valori veneti certificati non appena disponibili. [↑](#)
900. Analisi di sensibilità a una via: ciascun parametro è fatto variare del 25% in più e in meno, misurandone l'effetto sul beneficio monetario netto; il diagramma a tornado ordina i parametri per influenza, con l'efficacia clinica, i tassi di ricaduta e di cronicizzazione e il costo dello stato cronico tra i più influenti. [↑](#)
901. Incertezza strutturale: oltre all'incertezza dei parametri, l'incertezza sulla struttura e sulle assunzioni del modello è trattata mediante analisi di scenario, e i risultati sono riportati secondo lo standard CHEERS, con validazione della coerenza interna ed esterna. [↑](#)
902. Analisi di sensibilità probabilistica: il modello è eseguito diecimila volte con estrazione casuale dei parametri dalle rispettive distribuzioni (simulazione Monte Carlo), propagando l'incertezza dei parametri sull'incertezza del risultato. [↑](#)

903. Soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, valore di riferimento nella prassi italiana e internazionale. ↑
904. Curva di accettabilità della costo-efficacia: alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è dell'88,9% e la probabilità che sia dominante dell'84,6%; il beneficio monetario netto medio sulle diecimila iterazioni è di circa 7.815 euro per paziente, con intervallo di credibilità al 95% da circa -5.736 a circa +21.501 euro. ↑
905. Distinzione tra costo-utilità e impatto sul bilancio per il Veneto: la probabilità di costo-efficacia è un risultato di efficienza, riferito al singolo paziente, che valorizza il guadagno di salute e l'intera traiettoria di costo del modello; esso è coerente con il saldo diretto aggregato della Parte E, che per il Veneto è negativo, poiché la traduzione dal modello per paziente all'aggregato regionale incorpora le correzioni per peso morto e per l'effettiva monetizzabilità nel bilancio dei costi evitati, e poiché manca il canale della mobilità, essendo il Veneto regione creditrice. L'efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali. ↑
906. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. ↑
907. Priorità di acquisizione: i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso, essendo il canale della mobilità non applicabile in Veneto — sono quelli su cui il valore dell'informazione è più elevato e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati all'Azienda Zero. ↑
908. Verifica empirica: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le nove Aziende ULSS (stepped-wedge), oggetto della Parte L, riduce l'incertezza dei parametri sostituendo le stime con misure osservate sui dati veneti. ↑
909. Questa parte copre l'ottavo dominio del modello HTA, il profilo del paziente e sociale, e risponde al criterio di impatto della griglia di giudizio; l'equità è trattata come dimensione costitutiva della valutazione, secondo l'evoluzione che ha affiancato l'equità in salute agli obiettivi di esito, esperienza e costo. ↑
910. Gradiente sociale della salute mentale: le popolazioni in deprivazione presentano prevalenze più elevate di disturbi mentali comuni e un accesso più difficile ai servizi. In Veneto il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato, sicché il gradiente socio-economico non è il tratto distintivo: la dimensione propriamente territoriale dell'equità — la dualità fra la pianura produttiva e le aree montane del Bellunese e dell'Altopiano — prevale su quella socio-economica. ↑
911. La gratuità, la prossimità e l'assenza di stigma del servizio di primo livello abbattano le barriere economiche, geografiche e culturali che gravano in misura maggiore sulle popolazioni svantaggiate; in Veneto rileva in particolare l'abbattimento della barriera geografica nelle aree montane, dove la distanza dai servizi e la loro rarefazione sono il principale ostacolo all'accesso. ↑
912. Variabili di equità, accesso e protezione finanziaria seguite dallo studio: riduzione dei tempi di attesa per l'accesso psicologico, accessibilità geografica nelle aree montane, equità di esito tra gruppi, equità di genere, accesso per le popolazioni straniere e fragili e per le persone con disabilità, gratuità per i gruppi vulnerabili, copertura del bisogno non soddisfatto. ↑
913. Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA), secondo Cookson, Asaria e colleghi: estende la valutazione economica alla dimensione dell'equità, stimando come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l'effetto sulle disuguaglianze, mediante anni di vita ponderati per l'equità, indice di concentrazione e indici di disuguaglianza assoluta e relativa. ↑

914. Direzione del risultato distributivo: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove l'accesso è oggi più difficile — le aree montane e le popolazioni gravate dalle liste di attesa — i benefici dell'intervento si concentrano sui gruppi più svantaggiati nell'accesso, riducendo il gradiente territoriale negli esiti di salute mentale; l'intervento migliora l'esito medio e ne comprime al tempo stesso la disuguaglianza. ↑
915. Ponderazione distributiva: l'attribuzione di pesi maggiori ai benefici che ricadono sui più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, come riferimento conservativo, il rapporto beneficio-costi non ponderato già esposto nella Parte E, dell'ordine di 3,8-5,6 a uno. In Veneto, ove la popolazione non è prevalentemente deprivata, l'effetto della ponderazione sarebbe più contenuto che nel Mezzogiorno, il che rende la scelta non ponderata tanto più prudente. ↑
916. Algoritmo allocativo quale meccanismo operativo dell'equità: la distribuzione territoriale degli incarichi non segue la sola popolazione, ma pondera ciascun distretto per l'indice di vecchiaia, l'indice di deprivazione socioeconomica e la prevalenza di cronicità e multimorbidità, attribuendo pesi maggiori alle aree montane del Bellunese e dell'Altopiano e alle aree anziane del Polesine. ↑
917. Indice di deprivazione multipla: misura sintetica costruita su reddito, occupazione, istruzione, salute, condizione abitativa e ambiente, impiegata per individuare le aree prioritarie nell'allocazione degli incarichi. ↑
918. Divari territoriali in Veneto: il divario rilevante non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra la pianura densa e produttiva, ben servita, e le aree montane del Bellunese e dell'Altopiano, a popolazione anziana e dispersa e in spopolamento; il Bellunese è la provincia più anziana e l'unica con mortalità in crescita. In queste aree la sola presenza fisica di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio, integrato dalla telepsicologia. ↑
919. Liste di attesa, erosione degli organici e rete territoriale quali dimensioni di equità: in Veneto, dove il canale della mobilità recuperata non si applica essendo la regione creditrice, la principale leva distributiva è la riduzione delle liste di attesa, il contrasto all'erosione degli organici dei servizi di salute mentale e il completamento della rete territoriale, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato. ↑
920. Protezione finanziaria: il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata diretta per la psicoterapia, l'impoverimento connesso alle cure e le spese sanitarie catastrofiche, con beneficio maggiore per i redditi bassi, per i quali la psicoterapia privata è spesso inaccessibile. ↑
921. Copertura del bisogno non soddisfatto come equità: intercettare la quota inevasa del disagio — dell'ordine di 970.000 persone, in larga parte non intercettata — significa raggiungere proprio coloro che hanno minore probabilità di accedere spontaneamente ai servizi. ↑
922. Collegamento al monitoraggio: gli indicatori di equità — accesso per area e per livello socio-economico, gradiente dell'esito, tempi di attesa per area — fanno parte del sistema di indicatori della Parte L, e consentono di accertare nel tempo se il servizio raggiunga le comunità montane più distanti e i gruppi più fragili. ↑
923. Questa parte copre tre domini del modello HTA — il profilo etico (dominio 6), il profilo organizzativo (dominio 7) e il profilo giuridico (dominio 9) — che completano la valutazione oltre i piani già trattati. ↑
924. Profilo etico: le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato; la persona resta il soggetto, e mai l'oggetto, della presa in carico. ↑
925. Consenso informato: è modulare, prestato distintamente per i diversi trattamenti, e reso anche in forma digitale; nella salute mentale i dati sono ultrasensibili, sicché la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi possa accedervi. ↑

926. Conduzione etica della valutazione: gli esiti sono resi pubblici indipendentemente dal loro segno, a garanzia contro la distorsione da selezione dei risultati favorevoli, e l'intero impianto è sottoposto all'approvazione del comitato etico territorialmente competente. ↑
927. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante, senza che ne siano registrate le modalità. ↑
928. Articolo 32 della Costituzione e legge 23 dicembre 1978, n. 833: la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, e il Servizio sanitario nazionale fondato su universalità, eguaglianza ed equità. ↑
929. Articolo 117, terzo comma, della Costituzione: la tutela della salute è materia di competenza concorrente, nella quale allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio e l'organizzazione del servizio; gli atti regionali veneti operano legittimamente entro tale competenza, sul piano organizzativo. ↑
930. Articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è la leva attraverso cui un'eventuale legge statale potrebbe ricondurre la psicologia di base tra le prestazioni garantite in modo uniforme su tutto il territorio. ↑
931. Corte costituzionale, sentenza 13 dicembre 2021, n. 241: ha riconosciuto legittimo il modello regionale del servizio di psicologia di base, in quanto organizzazione del servizio sanitario che si avvale di professionisti già esistenti; è un precedente di rilievo diretto per il Veneto, che intende strutturare entro la propria competenza organizzativa una funzione già sperimentata e già oggetto di impegno politico. ↑
932. Base giuridica regionale del Veneto: la regione ha avviato la prima sperimentazione già nel 2014; con la mozione n. 302 del 2022 il Consiglio ha impegnato la Giunta ad avviare un servizio permanente di psicologia delle cure primarie; sono in corso d'esame proposte di legge dedicate; la cornice organizzativa di riferimento è la legge regionale n. 19 del 2016, istitutiva dell'Azienda Zero. La decisione non verte sul prevedere la funzione, già sperimentata e impegnata, ma sullo strutturarla e dimensionarla. ↑
933. Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2026: le Regioni in piano di rientro non possono utilizzare i fondi del proprio Servizio sanitario per finalità diverse dalla garanzia dei livelli essenziali. Il Veneto, con conti in equilibrio e non sottoposto a piano di rientro, non è soggetto a tale vincolo; permane il principio generale di destinazione delle risorse ai livelli essenziali, che la riforma rispetta. ↑
934. Deontologia professionale: il servizio opera nel rispetto delle norme deontologiche della professione, sotto la vigilanza dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, che concorre alla governance e alla formazione. ↑
935. Responsabilità clinica e ruolo dell'IA: l'impiego dell'intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali — il medico di medicina generale resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell'intervento psicologico, e l'IA è assimilata a un dispositivo di supporto, non a una figura che compie atti — sicché non si introduce una nuova figura professionale, ma uno strumento che assiste quelle esistenti. ↑
936. Conformità degli strumenti di IA: il regolamento europeo sull'IA classifica come ad alto rischio i sistemi impiegati nei dispositivi medici; il regolamento sui dispositivi medici impone la marcatura CE; il regolamento sulla protezione dei dati ne disciplina il trattamento; vi si innestano la supervisione umana costante, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias, la trasparenza e il divieto di discriminazione algoritmica. ↑

937. Equità digitale: per non generare nuove disuguaglianze, sono previsti canali tradizionali paralleli per chi non dispone di strumenti digitali — segnatamente le persone anziane delle aree montane del Bellunese e dell’Altopiano — e il supporto multilingue per le popolazioni straniere, ferma restando la garanzia dell’alternativa in presenza. ↑
938. Protezione dei dati: misure di sicurezza robuste — crittografia e pseudonimizzazione per le analisi — consenso modulare anche in forma digitale, collaborazione con l’Autorità garante e acquisizione di software dotati di marcatura adeguata secondo le normali procedure. ↑
939. Questa parte copre il settimo dominio del modello HTA, il profilo organizzativo, e fornisce il contenuto del caso commerciale e del caso gestionale del Five Case Model, rispondendo al criterio di sostenibilità. ↑
940. Modello RE-AIM: misura la riuscita e la validità esterna dell’attuazione lungo cinque dimensioni — la portata (quota della popolazione bersaglio raggiunta), l’efficacia (esiti conseguiti), l’adozione (adesione di sedi e professionisti), l’implementazione (fedeltà al modello) e il mantenimento (sostenibilità nel tempo). ↑
941. Quadro consolidato per la ricerca sull’implementazione (CFIR): spiega i determinanti dell’attuazione, articolati in cinque domini — le caratteristiche dell’innovazione, il contesto esterno, il contesto interno, gli individui coinvolti e il processo di attuazione — consentendo l’individuazione ex ante di barriere e facilitatori. ↑
942. Determinanti di implementazione seguiti dallo studio: il tasso di copertura, il grado di adozione delle sedi, la fedeltà al modello, i tempi di attivazione, il numero di psicologi reclutati e formati, la qualità della formazione e della supervisione, il grado di integrazione nei flussi di lavoro, l’aderenza ai percorsi e la scalabilità. ↑
943. Disegno del dispiegamento scaglionato in Veneto: le nove Aziende ULSS passano in sequenza, per fasi semestrali, dalla condizione di controllo a quella di intervento, a partire dalle aziende di maggiore dimensione e prontezza organizzativa, sino a coprire l’intera regione; l’ordine è definito dalla Giunta regionale su criteri trasparenti e reso noto preventivamente, con il coordinamento unitario dell’Azienda Zero. ↑
944. Doppia funzione del dispiegamento scaglionato: esso risponde a un’esigenza organizzativa — attivare il servizio in modo graduale, compatibile con i tempi del reclutamento e della formazione — e al tempo stesso costituisce il fondamento della valutazione controfattuale d’impatto, poiché la successione configura un esperimento naturale, oggetto della Parte L. ↑
945. Reclutamento: a fronte di un fabbisogno a regime dell’ordine di 1.050 psicologi, il reclutamento avviene tramite l’iscrizione a un elenco istituito presso ciascuna azienda e l’instaurazione di un rapporto convenzionale, con requisiti di iscrizione all’albo e di formazione specifica; in prima applicazione possono accedere i professionisti con pregressa esperienza nell’assistenza psicologica nel Servizio sanitario regionale, valorizzando l’esperienza maturata nelle sperimentazioni avviate dal 2014. ↑
946. Cronoprogramma: l’attivazione procede per fasi semestrali attraverso le nove Aziende ULSS; le attività di reclutamento, formazione, allestimento e avvio sono condotte in modo scaglionato, azienda per azienda, mentre il monitoraggio e la valutazione accompagnano l’intero arco e proseguono oltre il completamento. ↑
947. Soglia di riuscita del dispiegamento: tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% nella fase di attuazione, a fronte del valore di riferimento del programma inglese; il monitoraggio è chiamato a verificarne il raggiungimento sui dati veneti. ↑
948. Caso commerciale (Five Case Model): la fattibilità dell’assetto contrattuale poggia sul rapporto convenzionale ancorato all’accordo della specialistica ambulatoriale, da cui un costo medio per incarico dell’ordine di 55.000 euro l’anno e gli scenari di spesa di 30, 45 e 58 milioni già esposti nella Parte E; il

modello dell'elenco aziendale e del rapporto convenzionale è già adottato da altre Regioni e non richiede la creazione di nuove figure. ↑

949. Caso gestionale (Five Case Model): l'attuazione è governata su due livelli. A livello regionale, un comitato di indirizzo regionale esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, l'Azienda Zero, le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere universitarie, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, la medicina generale, la pediatria di libera scelta e le università di Padova e Verona; a livello aziendale, ciascuna Azienda ULSS è responsabile dell'attuazione nel proprio ambito, secondo la regia unitaria dell'Azienda Zero. ↑
950. Rischi attuativi e misure di mitigazione: i rischi principali — reclutamento insufficiente, debole adesione della medicina generale, interoperabilità incompleta dei sistemi informativi, disomogeneità territoriale e venir meno delle coperture — sono associati a misure dedicate; il dispiegamento graduale è esso stesso la principale forma di mitigazione, poiché consente di osservare, correggere e adattare prima dell'estensione. ↑
951. Caso finanziario e coperture (Five Case Model): le fonti di copertura comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, dell'ordine di 11 miliardi di euro, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'infrastruttura territoriale e digitale, e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali. ↑
952. Vincoli di bilancio: il Veneto dispone di un finanziamento dell'ordine di 11 miliardi di euro con conti in equilibrio e non è in piano di rientro; il costo del servizio, anche a massima copertura, ne costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale, agevolmente assorbibile, sicché la sostenibilità finanziaria è in Veneto più immediata che nelle regioni in difficoltà. ↑
953. Sostenibilità nel tempo (criterio OCSE-DAC): la sostenibilità è assicurata dalla modestia del costo rispetto al bilancio, dal forte ritorno sociale documentato e dall'istituzionalizzazione del servizio, già oggetto di impegno politico con la mozione n. 302 del 2022 e delle economie di scala consentite dall'Azienda Zero. ↑
954. Nota di cautela metodologica: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la verifica empirica sui dati veneti, prevista dalla Parte L, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate. ↑
955. Questa parte organizza la misurazione dell'intervento nel tempo: serve ex post i criteri della griglia di giudizio, chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione e fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti. ↑
956. Modello di Donabedian per la qualità dell'assistenza: distingue le dimensioni di struttura, processo ed esito, qui integrate dalla dimensione dell'impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società. ↑
957. Batteria di indicatori: circa cinquantotto misure articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti e circa quaranta richiedono la rilevazione diretta del servizio. ↑
958. Set di esiti essenziali: l'iniziativa COMET e gli standard ICHOM individuano, mediante consenso strutturato (metodo Delphi), un nucleo parsimonioso di esiti da misurare, evitando la proliferazione di misure ridondanti. ↑
959. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline: bisogno e domanda (disponibile), accesso ed equità (da rilevare), processo (da rilevare), esito clinico (da rilevare), economici (misto), impatto sociale (misto), organizzativi (da rilevare), variabili di sintesi (da calcolare); i divari tra Aziende ULSS sono tra le misure di equità. ↑
960. Protocollo minimo di rilevazione: attivo dal primo giorno, registra la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni, deliberatamente essenziale per non gravare sull'attività clinica. ↑

961. Strumenti di esito: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9), con punteggio totale da 0 a 27, soglia di rilevanza clinica intorno a 10 e cambiamento affidabile dell'ordine di 6 punti, e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7), impiegati nei soli punteggi complessivi. ↑
962. Modello di misurazione dei programmi inglesi di terapie psicologiche: la raccolta delle misure di esito a ogni seduta, e non solo all'inizio e alla fine, consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non protrarre percorsi inefficaci. ↑
963. Costituzione della baseline su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti — demografici, epidemiologici, di benessere, di mortalità — forniscono la fotografia del prima e vanno registrati subito; la rilevazione di servizio parte con il primo assistito. Ogni mese di ritardo nell'avvio è un mese di dati di base perduti. ↑
964. Calendario della rilevazione: prima dell'avvio, costituzione della baseline con i dati disponibili e predisposizione del registro e dei questionari; all'avvio, inizio della registrazione; in continuo, trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale con cadenza mensile; periodicamente, calcolo delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale. ↑
965. Valutazione controfattuale d'impatto: misura l'effetto causale dell'intervento confrontando gli esiti dei trattati con il controfattuale, ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente; lo strumento che la rende possibile è il disegno scaglionato del dispiegamento, idoneo esperimento naturale. ↑
966. Differenza-nelle-differenze: confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le Aziende ULSS già attivate e quelle non ancora attivate, sotto l'ipotesi di andamento parallelo; vi si affianca il controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata di unità non trattate. ↑
967. Effetti stimati e validità: l'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e l'effetto medio sui soli trattati; i disegni a esperimento naturale sono, per gli interventi di salute della popolazione, lo strumento raccomandato dalla letteratura metodologica; la validità esterna va valutata a parte. ↑
968. Trasformazione delle stime in prove: confrontando l'andamento, ad esempio, degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche nelle Aziende ULSS che hanno attivato il servizio con quello delle aziende che lo attiveranno, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata sui dati veneti. ↑
969. Verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (VIR; DPCM 169/2017): è valutazione ex post, di norma dopo un biennio, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, che chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva. ↑
970. Clausola valutativa: sul piano regionale, impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti; nel Veneto questo passaggio è già prefigurato dalla mozione n. 302 del 2022, ed è ciò che lega la misurazione tecnica alla responsabilità politica e alla trasparenza verso il legislatore regionale. ↑
971. Manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi (2008): articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione delle variabili alla normalizzazione, alla ponderazione e all'analisi di robustezza. ↑
972. Benessere Equo e Sostenibile (BES), ISTAT: dodici domini con indici compositi; con la legge n. 163/2016 di riforma del bilancio, una selezione di indicatori è entrata nel ciclo della programmazione economica, a precedente istituzionale dell'impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica. ↑
973. Regole di coerenza e di non duplicazione: il divieto di doppia contabilizzazione impone che, nel medesimo calcolo, una grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali già adottata nella Parte E. ↑

974. Questa parte conclusiva applica la griglia di giudizio del telaio, i criteri dell'OCSE-DAC, che attraversano l'intero studio come metro di valutazione e convergono qui nella sintesi; fornisce inoltre il contenuto del caso strategico del Five Case Model. ↑
975. Criteri di valutazione dell'OCSE-DAC (rivisti nel 2019, «Better Criteria for Better Evaluation»): sei lenti complementari — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità — che insieme danno un quadro complessivo dell'intervento. ↑
976. Rilevanza: l'intervento risponde a un bisogno reale e di grande dimensione — dell'ordine di 970.000 persone con disagio comune in larga parte inevaso — e all'obbligo di garantire i livelli essenziali. ↑
977. Coerenza: l'intervento è compatibile e complementare con gli standard dell'assistenza territoriale (DM 77/2022), con la Missione 6 del PNRR e con la base regionale veneta — la mozione n. 302 del 2022 e la legge regionale n. 19 del 2016 — ed è costituzionalmente difendibile; il Veneto, non sottoposto a piano di rientro, non incontra il vincolo di bilancio che grava sulle regioni in disavanzo. ↑
978. Efficacia: l'evidenza internazionale documenta che i modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie raggiungono gli obiettivi clinici, con tassi di recupero dell'ordine del 50% nel programma inglese. ↑
979. Efficienza: l'intervento è favorevole in termini di costo-utilità — con dominanza per paziente e costo-efficacia confermata dall'analisi probabilistica — a fronte, per il Veneto, di un saldo diretto negativo sul solo bilancio sanitario, di entità modesta rispetto a un finanziamento di 11 miliardi; l'efficienza allocativa è dunque elevata, la convenienza per il solo bilancio negativa. ↑
980. Impatto: l'impatto distributivo è favorevole, poiché i benefici si concentrano dove l'accesso è più difficile — le aree montane del Bellunese e dell'Altopiano e le popolazioni gravate dalle liste di attesa — riducendo il gradiente territoriale; il ritorno complessivo è dell'ordine di 3,8-5,6 a uno. ↑
981. Sostenibilità: l'intervento è finanziariamente sostenibile — a fronte di un costo modesto, di una pluralità di coperture e di un bilancio regionale in equilibrio — e organizzativamente, in quanto destinato all'istituzionalizzazione, già oggetto di impegno politico con la mozione n. 302 del 2022. ↑
982. Analisi multi-criterio (buone pratiche ISPOR): rende esplicito il bilanciamento dei criteri non riducibili a denaro — l'equità, la fattibilità, la coerenza strategica, la robustezza dell'evidenza — attribuendo a ciascuno un peso e a ciascuna opzione un punteggio. ↑
983. Risultato dell'analisi multi-criterio: su otto criteri pesati, l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 80,7 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri tranne la fattibilità immediata; il risultato è stabile rispetto ai pesi adottati. ↑
984. Le tre affermazioni del cruscotto decisionale per il Veneto: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, trascurabile rispetto a un finanziamento di 11 miliardi; il ritorno per la collettività è ampio (rapporto beneficio-costi di 3,8-5,6 a uno); il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali. ↑
985. Raccomandazione centrale: la decisione rilevante non è se prevedere il servizio — già sperimentato dal 2014 e oggetto dell'impegno assunto con la mozione n. 302 del 2022 — ma se strutturarne e dimensionarlo, portandolo dalla sperimentazione alla copertura del fabbisogno, dell'ordine di 1.050 incarichi. ↑
986. Cruscotto secondo il Quintuple Aim: la sintesi del valore è letta lungo le cinque dimensioni dell'esito di salute, dell'esperienza, del costo, del benessere degli operatori e dell'equità. ↑
987. Limite principale (radicamento nei dati): le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione veneta (8,2%), e non estratte dai conti regionali certificati dell'Azienda Zero e delle Aziende ULSS; tale sostituzione è la condizione per la presentazione agli organi di

controllo. ↑

988. Cautele di trasferibilità e di fonte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la cifra del ritorno è prudenziale e non ponderata per l'equità. ↑
989. Agenda di ricerca: l'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso l'Azienda Zero e le Aziende ULSS, seguito dall'avvio della rilevazione di servizio e dalla valutazione controfattuale sul dispiegamento scaglionato. ↑
990. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudenziale per l'ottimismo delle stime. ↑
991. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
992. Quadro economico consolidato per il Veneto (Parte E): a regime, da circa 530 a circa 1.050 psicologi, costo del servizio di 30-58 milioni, risparmi diretti di 18-45 milioni, ricadute sociali di 95-280 milioni; il saldo diretto è negativo, il saldo complessivo positivo, con rapporto beneficio-costi di 3,8-5,6 a uno. ↑
993. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
994. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio. ↑
995. Valori regionali di ancoraggio per il Veneto: popolazione di 4.853.472 abitanti (Censimento ISTAT 2024), finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 11 miliardi di euro con conti in equilibrio, saldo di mobilità attivo, fabbisogno a regime dell'ordine di 1.050 psicologi. ↑
996. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione veneta (8,2%), e non estratti dai conti regionali certificati; i dati da acquisire presso l'Azienda Zero e le Aziende ULSS sono elencati nella tabella seguente. ↑
997. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑
998. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni agli studi pugliese e lombardo, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑
999. Posizione del Friuli-Venezia Giulia: la Regione dispone di un impegno politico formalmente assunto e di una sperimentazione in fase di avvio, ma non ancora di una legge attuativa. Nel febbraio 2022 il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, con la sottoscrizione di tutti i Gruppi consiliari, una mozione che impegna la Giunta a istituire nelle Case della Comunità ambulatori di primo livello di assistenza psicologica nei quali operino psicologi delle cure primarie, con accesso diretto del cittadino o su invio di altri professionisti e per tutte le fasce d'età, e a potenziare i Dipartimenti di salute mentale, prevedendo altresì un Tavolo tecnico regionale interdisciplinare. Nel maggio 2026 il confronto fra la Regione e le rappresentanze professionali ha aperto alla sperimentazione della figura, in linea con la normativa nazionale. Il servizio si colloca quindi nelle Case della Comunità, con accesso diretto, ma la sua forma piena — inquadramento, dimensionamento e copertura — è ancora da definire in via legislativa e attuativa. ↑

000. Stato attuale e decisione: a differenza del Lazio, fermo a una proposta, e diversamente dalla Campania e dalla Sicilia, che hanno adottato leggi dedicate e un modello convenzionale, e dal Friuli-Venezia Giulia, che ha inquadrato il servizio in una legge di riforma con un modello dipartimentale, il Friuli-Venezia Giulia dispone di un impegno politico unanime — la mozione consiliare del 2022, sottoscritta da tutti i Gruppi — e di una sperimentazione in avvio, ma non ancora di una legge attuativa. La decisione rilevante, di conseguenza, non è se introdurre il servizio, già condiviso e in fase di sperimentazione, ma se dargli forma piena e strutturata: tradurre l'impegno politico in una legge regionale attuativa, definire l'inquadramento del personale, e dimensionare il servizio dalla sperimentazione iniziale alla copertura sistematica del fabbisogno — stimato nell'ordine di 260 psicologi nello scenario espansivo — entro l'autonomia propria di una regione a statuto speciale che si autofinanzia la sanità tramite compartecipazione ai tributi erariali e registra finanze solide e nessun piano di rientro. ↑
001. Salute mentale in Friuli-Venezia Giulia: la domanda è sospinta da componenti convergenti, con un profilo segnato dall'invecchiamento. La prima e più caratterizzante è il bisogno dell'età anziana e della cronicità, in una delle regioni più anziane d'Italia — terza per età media dopo Liguria e Sardegna — particolarmente accentuato nelle aree montane e interne della Carnia, del Friuli collinare e delle valli, dove la rarefazione dei servizi, le distanze e l'isolamento gravano sull'accesso. La seconda è il disagio giovanile e quello connesso alla precarietà socio-economica, presente soprattutto nei centri di Trieste, Udine e Pordenone e nelle realtà universitarie. La terza è la dimensione linguistica e culturale, propria di una regione plurilingue in cui convivono italiano, friulano, sloveno e tedesco. A queste si aggiungono i divari di accesso propri di una regione di confine, la pressione delle liste di attesa e il bisogno, non sempre intercettato, della componente straniera. ↑
002. Popolazione residente in Friuli-Venezia Giulia di 1.194.616 abitanti (Censimento permanente ISTAT, 1° gennaio 2024), pari a circa il 2,0% della popolazione nazionale e sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, per effetto di saldi migratori positivi — con l'estero e con le altre regioni — che compensano un saldo naturale fortemente negativo e una natalità ai minimi storici. La distribuzione è concentrata sulle province di Udine, che con oltre 500.000 residenti raccoglie il 43,3% della popolazione, e di Pordenone, che con oltre 300.000 ne raccoglie il 26,0%: insieme quasi il 70%; le province di Trieste e Gorizia ospitano il restante 30,7%. Quasi il 30% della popolazione vive nei tre comuni con oltre 50.000 abitanti, Trieste, Udine e Pordenone. La struttura per età è fra le più anziane d'Italia, con un'età media di 48,5 anni — la terza più elevata dopo Liguria e Sardegna — e un indice di vecchiaia di 244,1 ultrasessantacinquenni ogni cento giovani sotto i quindici anni; la componente straniera è il 10,1% della popolazione, con prevalenza di cittadinanze rumena, albanese e bangladese. ↑
003. Le quattro cornici metodologiche apicali adottate: il modello centrale dell'HTA di EUnetHTA (nove domini), oggi nella cornice del Regolamento UE 2021/2282 sull'Health Technology Assessment, applicabile dal gennaio 2025; il Five Case Model del Green Book del Tesoro del Regno Unito; lo standard CHEERS 2022 per il reporting delle valutazioni economiche; e i criteri di valutazione dell'OCSE-DAC. ↑
004. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; il comparatore è dato dall'assetto attuale, fatto di iniziative frammentarie e dalla sperimentazione in avvio, prima della strutturazione in un modello pieno. ↑
005. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute. Il modello incorpora una correzione prudenziale per la tendenza, documentata nella letteratura sulla valutazione degli investimenti pubblici, a sottostimare i costi e a sovrastimare i benefici. ↑

006. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. Il profilo finanziario del Friuli-Venezia Giulia presenta una condizione propria e relativamente favorevole: regione a statuto speciale, essa autofinanzia la sanità con risorse del proprio territorio attraverso la compartecipazione ai tributi erariali, senza che lo Stato concorra al finanziamento del Servizio sanitario regionale; non è sottoposta a piano di rientro e presenta finanze solide. Sul versante della mobilità sanitaria, la posizione di confine con Slovenia e Austria genera flussi nei due sensi, con un saldo contenuto, e la mobilità non riguarda la domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero è per questo intervento solo modestamente pertinente. Ne consegue un saldo diretto lievemente negativo ma modesto, agevolmente sostenibile entro l'autonomia finanziaria regionale; il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi. ↑
007. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (2,0%) e non estratti dai conti regionali certificati delle tre aziende sanitarie regionali, dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute e degli istituti a rilievo nazionale: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare prima della presentazione esterna. Poiché il servizio è ancora in fase di sperimentazione e non a regime, il Friuli-Venezia Giulia dispone di una base di dati operativi propri limitata; lo studio poggia perciò, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, e la sperimentazione in avvio costituirà la fonte primaria da consolidare. ↑
008. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
009. Valutazione controfattuale d'impatto: poiché la strutturazione del modello pieno avverrà in tempi differenziati fra i distretti delle tre aziende sanitarie regionali, il disegno può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione del servizio tra i distretti delle tre aziende sono impiegati a fini valutativi. L'effetto causale è stimato con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico; la sperimentazione in avvio consente di rilevare una linea di base prima della piena operatività. ↑
010. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo che riunisce la Regione (Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità), le tre aziende sanitarie regionali — l'Azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina (ASUGI), l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) — l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), gli istituti a rilievo nazionale (IRCCS materno-infantile Burlo Garofolo, CRO di Aviano), l'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei di Trieste e Udine. Il Friuli-Venezia Giulia dispone di un'azienda regionale di coordinamento per la salute, l'ARCS, accanto al coordinamento della Direzione centrale salute, e del Tavolo tecnico regionale interdisciplinare previsto dalla mozione del 2022. La sfida del governo non è quindi introdurre il servizio, già condiviso, ma dargli forma piena e condurlo a regime, strutturandolo nei distretti delle tre aziende sanitarie e garantendo l'omogeneità attuativa nell'unico sistema sanitario regionale. ↑
011. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce l'infrastruttura per la raccolta uniforme. ↑
012. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑

013. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. [↑](#)
014. Popolazione residente in Sardegna 1.194.616 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 2,0% del totale nazionale, in calo di 8.072 unità rispetto all'anno precedente sostanzialmente stabile; la diminuzione, che non risparmia alcuna provincia, è dovuta a un saldo naturale fortemente negativo e a un saldo migratorio interno negativo, solo in parte compensati dal saldo migratorio estero, positivo. La denatalità ha toccato un nuovo minimo, con una fecondità fra le più basse del Paese. [↑](#)
015. Struttura per età: il Friuli-Venezia Giulia è fra le regioni più anziane d'Italia, con un'età media di 48,5 anni, la terza più elevata dopo Liguria e Sardegna, e un indice di vecchiaia di 244,1 ultrasessantacinquenni ogni cento giovani sotto i quindici anni, più del doppio. La speranza di vita alla nascita è fra le più alte del Paese (81,2 anni per gli uomini e 85,7 per le donne nel 2023). La distribuzione interna è disomogenea: le aree montane e interne della Carnia, del Friuli collinare e delle valli registrano l'invecchiamento più accentuato; la componente straniera, più giovane, concorre solo in parte al ringiovanimento. [↑](#)
016. Componente straniera del 10,1% dei residenti (circa 120.000 persone), in linea con la media nazionale, con prevalenza di cittadinanze rumena (20,5%), albanese e bangladese, e una concentrazione maggiore nei centri urbani e nelle aree produttive; fra gli stranieri la quota di minori è più elevata che nella popolazione complessiva, sicché la competenza culturale e la mediazione linguistica restano rilevanti, soprattutto per l'intercettazione del disagio nelle famiglie immigrate e nei loro figli. [↑](#)
017. Distribuzione territoriale concentrata sulle due province maggiori: la provincia di Udine, con oltre 500.000 residenti, raccoglie il 43,3% della popolazione, e quella di Pordenone, con oltre 300.000, il 26,0%: insieme quasi il 70%. Le province di Trieste e Gorizia ospitano il restante 30,7%. Quasi il 30% della popolazione vive nei tre comuni con oltre 50.000 abitanti — Trieste, Udine e Pordenone — mentre una quota analoga risiede in piccoli comuni, molti dei quali nelle aree montane e interne in spopolamento. [↑](#)
018. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato i centri urbani di Trieste, Udine e Pordenone, che concentrano popolazione, servizi e disagio giovanile e socio-economico; dall'altro le aree montane e interne della Carnia, del Friuli collinare, della Val Canale e delle valli, più anziane, in spopolamento e a bassa densità, dove la rarefazione dei servizi, le distanze e l'orografia acuiscono le difficoltà di accesso. È l'asse di disuguaglianza territoriale più caratterizzante della regione, cui si affianca quello linguistico. [↑](#)
019. Disagio psichico comune o sottosoglia stimato nell'ordine di 239.000 persone, ottenuto per proiezione dei tassi di prevalenza nazionali sulla popolazione regionale; è la quota di bisogno potenziale cui il servizio si rivolge in via prioritaria, in larga parte non intercettata dall'offerta, tanto più in una fase in cui il servizio è ancora in avvio sperimentale. [↑](#)
020. Domanda specialistica e posizione della regione: a fronte del disagio comune si colloca un'ampia utenza in carico ai servizi di salute mentale, dell'ordine di alcune decine di migliaia di persone secondo una stima rapportata ai dati nazionali. Il Friuli-Venezia Giulia presenta una specificità propria: il Consiglio regionale si è impegnato all'unanimità, con la mozione del 2022, a introdurre il servizio nelle Case della Comunità, e una sperimentazione è in avvio, circostanza che conferisce all'intervento un consenso politico già acquisito, sebbene la base di dati operativi propri sia ancora limitata. [↑](#)
021. Bisogno dell'età anziana e della cronicità: è la componente più caratterizzante del Friuli-Venezia Giulia, fra le regioni più anziane d'Italia. La comorbidità psicologica delle patologie croniche, la solitudine e il carico assistenziale sui familiari gravano in misura crescente, in modo particolare nelle aree montane e interne della Carnia e delle valli, dove l'invecchiamento è più accentuato e l'accesso ai servizi più difficile. [↑](#)

022. Disagio giovanile e connesso al lavoro: nei centri di Trieste, Udine e Pordenone e nelle realtà universitarie, la pressione prestazionale, la precarietà e le condizioni socio-economiche concorrono al disagio psichico, con fenomeni di ansia, depressione e disturbi del comportamento alimentare tra gli adolescenti e i giovani adulti; l'intercettazione precoce ha un valore particolarmente elevato in termini di salute e di equità, anche in funzione del contenimento dell'emigrazione giovanile. ↑
023. Spopolamento e isolamento delle aree montane e interne: la progressiva rarefazione della popolazione e dei servizi nella Carnia, nel Friuli collinare e nelle valli, con piccoli comuni sempre più anziani, genera isolamento sociale e difficoltà di accesso che si traducono in domanda di salute mentale inesausta; è un fattore di bisogno specifico della regione, che un primo livello territoriale accessibile, sostenuto dalla telepsicologia, può in parte intercettare. ↑
024. Tratto distintivo del Friuli-Venezia Giulia rispetto alle altre regioni: la combinazione di una regione di confine e fra le più anziane d'Italia; di un servizio non ancora disciplinato per legge ma sostenuto da un impegno politico unanime (la mozione consiliare del 2022) e da una sperimentazione in avvio; di un unico sistema sanitario regionale con tre aziende e un'azienda di coordinamento (ARCS); dello statuto speciale che autofinanzia la sanità tramite compartecipazione ai tributi erariali, senza piano di rientro; e di un quadrilinguismo riconosciuto — italiano, friulano, sloveno e tedesco. Il bisogno è quindi accompagnato da un forte consenso, ma da un'attuazione ancora iniziale, che la decisione è chiamata a portare a regime in forma strutturata. ↑
025. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche significativi: rapportando alla popolazione regionale il dato nazionale, dell'ordine di alcune migliaia l'anno, indice di una pressione sul sistema acuto che un primo livello territoriale pienamente strutturato potrebbe in parte contenere a monte, tanto più rilevante in un'isola dove le distanze rendono l'accesso al pronto soccorso più oneroso. ↑
026. Offerta territoriale: il Friuli-Venezia Giulia non dispone ancora di una legge attuativa, ma di un impegno politico formalmente assunto e di una sperimentazione in avvio. Nel febbraio 2022 il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione che impegna a istituire negli ambulatori delle Case della Comunità un primo livello di assistenza psicologica con psicologi delle cure primarie, ad accesso diretto del cittadino o su invio, per tutte le età, e a potenziare i Dipartimenti di salute mentale; nel maggio 2026 il confronto fra la Regione e le rappresentanze professionali ha aperto alla sperimentazione della figura, in linea con la normativa nazionale. La forma piena del servizio — inquadramento, dimensionamento e copertura — è ancora da definire. ↑
027. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 260 psicologi nello scenario espansivo (e dell'ordine di 130 e 195 negli scenari conservativo e di base). L'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia e le rappresentanze sindacali della categoria, che da anni sollecitano l'introduzione del servizio e ne hanno promosso la mozione consiliare, ne sostengono la strutturazione in un modello pieno e l'estensione a regime in tutte le aziende. ↑
028. Copertura attuale del fabbisogno: la sperimentazione in avvio è sufficiente a inaugurare l'esperienza ma non a coprire il fabbisogno regionale a regime. La decisione, di conseguenza, non verte sull'introdurre il servizio, già condiviso, ma sul dargli forma piena: tradurre l'impegno politico in una legge attuativa, strutturarne nei distretti delle tre aziende sanitarie e dimensionarlo verso la copertura piena del fabbisogno. ↑
029. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante nel Friuli-Venezia Giulia si gioca su due assi. Il primo, territoriale, separa i centri urbani di Trieste, Udine e Pordenone dalle aree montane e interne della Carnia, del Friuli collinare e delle valli, più anziane, in spopolamento e penalizzate dalle distanze: è l'asse più caratterizzante. Il secondo, linguistico, attiene alla necessità di un servizio fruibile dalle comunità friulana, slovena e tedesca nella propria lingua. La telepsicologia assistita è lo strumento per avvicinare l'offerta alle aree montane e interne, dove la presenza di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio. ↑

030. Finanziamento del Servizio sanitario regionale; in quanto regione a statuto speciale, il Friuli-Venezia Giulia autofinanzia la sanità con risorse del proprio territorio attraverso la compartecipazione ai tributi erariali, senza che lo Stato concorra al finanziamento del Servizio sanitario regionale (la disciplina vigente decorre dall'accordo Stato-Regione del 2019). La regione non è sottoposta a piano di rientro e presenta finanze solide; il costo del servizio, contenuto entro lo 0,3-0,6% della spesa sanitaria, è agevolmente sostenibile entro l'autonomia finanziaria regionale come scelta allocativa. ↑
031. Mobilità sanitaria: il Friuli-Venezia Giulia presenta un saldo passivo dell'ordine di cento milioni di euro l'anno, pari a circa il dieci per cento della spesa per ricoveri, con un costo cumulato nell'ultimo decennio dell'ordine di ottocento milioni. La fuga si concentra però nei ricoveri ad alta complessità e nelle terapie oncologiche — una mobilità dettata da necessità, e non da scelta, per l'inadeguatezza dell'offerta nell'Isola — e non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. ↑
032. Cornice normativa e programmatica: il Friuli-Venezia Giulia non dispone ancora di una legge attuativa, ma di una mozione consiliare approvata all'unanimità nel 2022, che impegna la Giunta a istituire il servizio nelle Case della Comunità, e di una sperimentazione aperta nel 2026. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale, il quadro di tutela delle minoranze linguistiche (legge 482/1999 e legge 38/2001 per la minoranza slovena) e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera. Rispetto al Lazio, fermo a una proposta, e alla Campania, alla Sicilia e alla Sardegna, che hanno adottato leggi dedicate, il Friuli-Venezia Giulia si colloca in una posizione intermedia: un impegno politico unanime e una sperimentazione, da tradurre in legge attuativa, entro l'autonomia propria dello statuto speciale. ↑
033. Definizione: lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Nel Friuli-Venezia Giulia tale funzione è oggetto di un impegno politico unanime — la mozione consiliare del 2022 — che ne prevede la collocazione negli ambulatori di primo livello delle Case della Comunità, con accesso diretto; la sua disciplina attuativa è ancora da definire. ↑
034. Teoria del cambiamento: la catena logica collega il bisogno (disagio comune diffuso e non intercettato) all'attività (presa in carico psicologica di prossimità), agli esiti clinici (recupero dei quadri lievi-moderati), di sistema (riduzione di accessi impropri, prescrizioni inappropriate e liste di attesa) e sociali (recupero di produttività e di funzionamento), per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria. ↑
035. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 239.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato, tanto più in una fase in cui il servizio è ancora in avvio sperimentale; poiché il servizio è condiviso politicamente ma non ancora strutturato a regime, l'intervento va dimensionato a partire dalla sperimentazione iniziale ed esteso verso il fabbisogno a regime nei distretti delle tre aziende sanitarie. ↑
036. Modello organizzativo: lo psicologo delle cure primarie opera nelle Case della Comunità e nei distretti sanitari, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impostazione della mozione consiliare del 2022, che prevede ambulatori di primo livello di assistenza psicologica ad accesso diretto del cittadino o su invio. La forma piena dell'inquadramento — convenzionale o dipendente — è ancora da definire in sede legislativa. Il Friuli-Venezia Giulia dispone di un'unico sistema sanitario regionale con tre aziende e di un'azienda regionale di coordinamento per la salute, l'ARCS, sicché la strutturazione omogenea del servizio nei distretti delle tre aziende sanitarie è la sfida organizzativa principale, agevolata dal coordinamento dell'ARCS. ↑
037. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑

038. Percorso clinico: accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista; valutazione iniziale e progetto clinico individuale; ciclo di colloqui brevi e programma di sostegno personalizzato; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. Il percorso, in via di strutturazione nei distretti delle tre aziende sanitarie, affronta i quadri più frequenti — sintomatologia ansioso-depressiva, problemi di adattamento, fasi del ciclo di vita, disagi emotivi transitori, problematiche psicosomatiche. ↑
039. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
040. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
041. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
042. Sistema informativo e interoperabilità: la registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con il sistema informativo sanitario regionale e con il fascicolo sanitario elettronico, consente il monitoraggio continuo e la valutazione; il coordinamento informativo è agevolato dalla presenza dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), che assicura funzioni tecnico-amministrative centralizzate, e deve garantire l'uniformità della rilevazione fra le tre aziende sanitarie man mano che il servizio vi viene strutturato. ↑
043. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale. Poiché il servizio è ancora in avvio, il flusso informativo va impostato fin dall'inizio in forma uniforme fra le tre aziende sanitarie, avvalendosi del coordinamento dell'ARCS e cogliendo l'opportunità di una rilevazione progettata correttamente prima della piena operatività. ↑
044. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑
045. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
046. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
047. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: nel Friuli-Venezia Giulia sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle aree montane e interne della Carnia, del Friuli collinare, della Val Canale e delle valli, più anziane e a bassa densità, dove le distanze e l'orografia rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi, e per mettere a disposizione, anche a distanza, personale nella lingua del paziente — friulano, sloveno o tedesco; tali strumenti sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza, e assumono un rilievo particolare in una delle regioni più anziane d'Italia. ↑
048. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
049. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso gli atenei di Trieste e Udine e la SISSA); post-universitario specialistico (formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, comprensiva della competenza per l'età anziana e la cronicità, prioritaria in una delle regioni più anziane d'Italia, per il disagio giovanile e per le competenze linguistiche in friulano, sloveno e tedesco); continuo

lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). Il Friuli-Venezia Giulia presenta qui un elemento di metodo: l'Ordine professionale regionale ha già promosso l'introduzione del servizio, base su cui innestare il percorso formativo dedicato. ↑

050. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. ↑
051. Posizione giuridica dell'Emilia-Romagna: la Regione non ha approvato una legge regionale dedicata, ma dispone di una funzione psicologica nelle cure primarie già ampiamente diffusa attraverso atti amministrativi e sperimentazioni aziendali — la Consultazione Psicologica Primaria, le linee di indirizzo regionali sull'Area «Psicologia Clinica e di Comunità» (deliberazione di Giunta n. 1141 del 2021) e quelle per l'implementazione della psicologia nelle Case della Comunità (deliberazione n. 2185 del 2023). Sono in corso d'esame il progetto di legge n. 8841 del 2024 e una proposta di legge di iniziativa popolare, oltre a un atto di indirizzo del 2021. La cornice di riferimento è la rete delle Case della Comunità, il cui percorso è stato avviato nel 2010. ↑
052. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. ↑
053. Priorità di acquisizione: i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso, essendo il canale della mobilità non applicabile in Emilia-Romagna — sono quelli su cui il valore dell'informazione è più elevato e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati alle Aziende USL e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie. ↑
054. Verifica empirica: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Aziende USL (stepped-wedge), oggetto della Parte L, riduce l'incertezza dei parametri sostituendo le stime con misure osservate sui dati emiliano-romagnoli. ↑
055. Disagio giovanile: l'indagine regionale «Tra presente e futuro. Essere adolescenti in Emilia-Romagna nel 2022» rileva, nella fascia 11-18 anni, che il 12,6% dei ragazzi ricorre a supporti psicologici o farmacologici per problemi d'ansia, l'11,6% per il senso di solitudine e l'11,5% per il disagio scolastico; trattandosi di problemi già presi in carico, essi rappresentano presumibilmente solo una frazione del bisogno reale. ↑
056. Salute mentale connessa al lavoro: in un'economia dinamica, a elevata occupazione e a forte tessuto manifatturiero, ampia parte dei lavoratori è esposta a fattori di stress correlati al lavoro; l'intercettazione precoce del disagio nella popolazione attiva ha un valore particolarmente elevato in termini di produttività recuperata. ↑
057. Bisogno dell'età anziana: la domanda connessa all'invecchiamento, alla cronicità e alla comorbidità psicologica delle patologie croniche è accentuata nelle aree appenniniche, più anziane e a maggiore difficoltà di accesso, in un contesto di elevata qualità dell'assistenza domiciliare. ↑
058. Bisogno connesso alla popolazione multiculturale: la quota di cittadini stranieri, pari al 12,6%, configura un bisogno specifico che il servizio, integrato nelle cure primarie, è in grado di intercettare con approccio culturalmente competente e con attenzione all'accesso linguistico; è un tratto distintivo del fabbisogno emiliano-romagnolo rispetto ad altre regioni. ↑
059. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche stimati nell'ordine di 40.000-43.000 l'anno, per proiezione dai 573.663 accessi psichiatrici nazionali rilevati nel 2023 dal Rapporto sulla salute mentale del Ministero della Salute; una quota è riconducibile a disagio comune non intercettato a monte. ↑

060. Offerta territoriale: l'Emilia-Romagna dispone di una funzione psicologica nelle cure primarie già ampiamente diffusa per via amministrativa — la Consultazione Psicologica Primaria, accessibile su invio del medico di medicina generale, le deliberazioni di Giunta n. 1141 del 2021 e n. 2185 del 2023, e progetti aziendali consolidati, tra cui «Lo Psicologo nella Casa della Salute» dell'AUSL di Bologna, attivo dal 2015, l'integrazione tra Nuclei delle Cure Primarie e Servizio di Psicologia dell'AUSL di Modena e l'esperienza dell'AUSL della Romagna — ma non ancora di un servizio strutturato e dimensionato in modo uniforme. ↑
061. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 970 psicologi (intervallo 930-1.020). L'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, per voce del presidente Gabriele Raimondi, indica come obiettivo la presenza di uno psicologo in ogni Casa della Comunità e di almeno un professionista in ognuno dei trentotto distretti della regione, a fronte di circa ottomila psicologi operanti in regione, dei quali meno del 10% nel servizio pubblico. ↑
062. Copertura attuale del fabbisogno parziale e disomogenea: la funzione esiste ma non è dimensionata a regime né uniforme tra le aziende; i soli psicologi del servizio sanitario pubblico hanno sostenuto, in un anno, oltre diecimila colloqui, cifra rilevante a fronte della loro esiguità numerica. ↑
063. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante in Emilia-Romagna non è un gradiente di deprivazione né una frattura Nord-Sud, ma si articola su tre assi — la dualità fra la pianura urbana densamente popolata e le aree appenniniche anziane e in spopolamento, dove l'accesso è più difficoltoso; la dimensione multiculturale, con una quota di stranieri del 12,6% che richiede una cura culturalmente competente; e le liste di attesa specialistiche, presenti anche in un sistema efficiente. La telepsicologia assistita e la competenza culturale sono gli strumenti per ridurli. ↑
064. Finanziamento del Servizio sanitario regionale superiore ai dieci miliardi di euro; il sistema è riconosciuto come benchmark nazionale dalla Corte dei Conti per il triennio 2022-2024, riferimento per i costi standard e con punteggi elevati nei Livelli Essenziali di Assistenza. Il disavanzo è stato coperto integralmente dalla Regione e ridotto progressivamente — da circa 194 milioni di euro nel 2024 a circa 70 milioni nel 2025 — verso il pareggio, con uno stanziamento regionale dell'ordine di 500 milioni e il mantenimento del Fondo per la non autosufficienza più elevato d'Italia; la regione non è soggetta a piano di rientro. ↑
065. Mobilità sanitaria a saldo attivo dell'ordine di +525 milioni di euro (2024): l'Emilia-Romagna è tra le poche regioni — con Lombardia e Veneto — che concentrano oltre la metà della mobilità attiva nazionale. Essendo la regione creditrice e attrattore netto di pazienti, il canale del recupero della mobilità passiva non si applica. ↑
066. Cornice normativa e programmatica: il percorso delle Case della Salute, avviato nel 2010 (deliberazione di Giunta n. 291/2010); le linee di indirizzo regionali sulla psicologia clinica e di comunità (deliberazione n. 1141/2021) e sull'implementazione della psicologia nelle Case della Comunità (deliberazione n. 2185/2023); il progetto di legge n. 8841 del 2024 e la proposta di legge di iniziativa popolare del 2024, in corso d'esame; la risoluzione consiliare del 2021; il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale; sul piano nazionale, il testo unificato C. 1140 in discussione alla Camera, il Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021, che ha confermato la legittimità della competenza regionale in materia; in assenza, allo stato, di una legge regionale dedicata approvata. ↑
067. Popolazione residente in Emilia-Romagna 4.451.938 abitanti (Censimento permanente ISTAT 2024), pari a circa il 7,5% della popolazione nazionale; la regione presenta un tratto raro nel panorama italiano, la crescita della popolazione, in termini assoluti seconda soltanto alla Lombardia, sostenuta da un saldo migratorio positivo che compensa il saldo naturale negativo; nove province, con la sola Bologna oltre il milione di abitanti (22,9%), seguita da Modena (15,9%), e una marcata variabilità interna tra la pianura urbana e le aree appenniniche. ↑

068. ↑

069. Popolazione residente in Emilia-Romagna 4.451.938 abitanti (Censimento permanente ISTAT 2024), pari a circa il 7,5% della popolazione nazionale; la regione presenta un tratto raro nel panorama italiano, la crescita della popolazione, in termini assoluti seconda soltanto alla Lombardia, sostenuta da un saldo migratorio positivo che compensa il saldo naturale negativo; nove province, con la sola Bologna oltre il milione di abitanti (22,9%), seguita da Modena (15,9%), e una marcata variabilità interna tra la pianura urbana e le aree appenniniche. Questa parte copre l'ottavo dominio del modello HTA, il profilo del paziente e sociale, e risponde al criterio di impatto della griglia di giudizio; l'equità è trattata come dimensione costitutiva della valutazione, secondo l'evoluzione che ha affiancato l'equità in salute agli obiettivi di esito, esperienza e costo. ↑
070. Gradiente sociale della salute mentale: le popolazioni in deprivazione presentano prevalenze più elevate di disturbi mentali comuni e un accesso più difficile ai servizi. In Emilia-Romagna il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato, sicché il gradiente socio-economico non è il tratto distintivo dell'equità; prevalgono due dimensioni diverse: la dualità fra la pianura produttiva e le aree appenniniche, e la dimensione multiculturale, propria di una regione con una quota di residenti stranieri del 12,6%. ↑
071. La gratuità, la prossimità e l'assenza di stigma del servizio di primo livello abbattano le barriere economiche, geografiche e culturali che gravano in misura maggiore sulle popolazioni svantaggiate; in Emilia-Romagna rilevano in particolare l'abbattimento della barriera geografica nelle aree appenniniche, dove la distanza dai servizi è il principale ostacolo, e quello della barriera linguistico-culturale per la popolazione straniera. ↑
072. Variabili di equità, accesso e protezione finanziaria seguite dallo studio: riduzione dei tempi di attesa per l'accesso psicologico, accessibilità geografica nelle aree appenniniche, equità di esito tra gruppi, equità di genere, accesso per la popolazione straniera e per i gruppi fragili e le persone con disabilità, gratuità per i gruppi vulnerabili, copertura del bisogno non soddisfatto. ↑
073. Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA), secondo Cookson, Asaria e colleghi: estende la valutazione economica alla dimensione dell'equità, stimando come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l'effetto sulle disuguaglianze, mediante anni di vita ponderati per l'equità, indice di concentrazione e indici di disuguaglianza assoluta e relativa. ↑
074. Direzione del risultato distributivo: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove l'accesso è oggi più difficile — le aree appenniniche, la popolazione straniera e i gruppi gravati dalle liste di attesa — i benefici dell'intervento si concentrano sui gruppi più svantaggiati nell'accesso, riducendo il gradiente territoriale negli esiti di salute mentale; l'intervento migliora l'esito medio e ne comprime al tempo stesso la disuguaglianza. ↑
075. Ponderazione distributiva: l'attribuzione di pesi maggiori ai benefici che ricadono sui più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, come riferimento conservativo, il rapporto beneficio-costi non ponderato già esposto nella Parte E, dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. In Emilia-Romagna, ove la popolazione non è prevalentemente deprivata, l'effetto della ponderazione sarebbe più contenuto che nel Mezzogiorno, il che rende la scelta non ponderata tanto più prudente. ↑
076. Algoritmo allocativo quale meccanismo operativo dell'equità: la distribuzione territoriale degli incarichi non segue la sola popolazione, ma pondera ciascun distretto per l'indice di vecchiaia, l'indice di deprivazione socioeconomica, la prevalenza di cronicità e multimorbidità e la presenza straniera, attribuendo pesi maggiori alle aree appenniniche e anziane e alle aree urbane a forte presenza migratoria. ↑
077. Indice di deprivazione multipla: misura sintetica costruita su reddito, occupazione, istruzione, salute, condizione abitativa e ambiente, impiegata per individuare le aree prioritarie nell'allocazione degli incarichi. ↑

078. Divari territoriali in Emilia-Romagna: il divario rilevante non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra la pianura densa e produttiva, ben servita, e le aree appenniniche, a popolazione anziana e dispersa e in spopolamento. In queste aree la sola presenza fisica di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio, integrato dalla telepsicologia. [↑](#)
079. Liste di attesa, completamento della funzione e dimensione multiculturale quali dimensioni di equità: in Emilia-Romagna, dove il canale della mobilità recuperata non si applica essendo la regione creditrice, le principali leve distributive sono la riduzione delle liste di attesa, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato, il completamento uniforme della funzione fra le otto Aziende USL e la cura culturalmente competente per la popolazione straniera. [↑](#)
080. Protezione finanziaria: il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata diretta per la psicoterapia, l'impovertimento connesso alle cure e le spese sanitarie catastrofiche, con beneficio maggiore per i redditi bassi, per i quali la psicoterapia privata è spesso inaccessibile. [↑](#)
081. Copertura del bisogno non soddisfatto come equità: intercettare la quota inevasa del disagio — dell'ordine di 890.000 persone, in larga parte non intercettata — significa raggiungere proprio coloro che hanno minore probabilità di accedere spontaneamente ai servizi. [↑](#)
082. Collegamento al monitoraggio: gli indicatori di equità — accesso per area e per livello socio-economico, accesso della popolazione straniera, gradiente dell'esito, tempi di attesa per area — fanno parte del sistema di indicatori della Parte L, e consentono di accertare nel tempo se il servizio raggiunga le comunità appenniniche più distanti e i gruppi più fragili. [↑](#)
083. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; servizio attuale come comparatore. [↑](#)
084. [↑](#)
085. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; servizio attuale come comparatore. Metodo della revisione: la sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche (PRISMA 2020) e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE; sono considerati studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. [↑](#)
086. Studio fondativo del modello collaborativo (IMPACT), pubblicato su JAMA nel 2002: circa il 50% dei pazienti trattati ha conseguito una riduzione di almeno il 50% dei sintomi a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. [↑](#)
087. Meta-analisi su cinquantasette studi controllati (2012): l'integrazione della cura ha prodotto un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard rispetto alla cura usuale. [↑](#)
088. Revisione di quarantadue implementazioni del modello (2024): riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 43% dell'ansia a sei mesi, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. [↑](#)
089. Programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies), dati reali 2023-2024: tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile del 67,8% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su una scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno. [↑](#)
090. Meta-analisi sulle cure integrate: coefficiente standardizzato dell'ordine di -0,11 sui sintomi depressivi, di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante quando applicato a una popolazione ampia. [↑](#)

091. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. ↑
092. Cautela metodologica rilevante: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi (l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero); il valore economico del modello poggia in misura preponderante sui ritorni sociali, non sui risparmi sanitari diretti. Questa cautela è coerente con il profilo del caso economico emiliano-romagnolo, fondato anch'esso sulle ricadute sociali. ↑
093. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. ↑
094. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. ↑
095. ↑
096. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. Questa parte copre tre domini del modello HTA — il profilo etico (dominio 6), il profilo organizzativo (dominio 7) e il profilo giuridico (dominio 9) — che completano la valutazione oltre i piani già trattati. ↑
097. Profilo etico: le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato; la persona resta il soggetto, e mai l'oggetto, della presa in carico. ↑
098. Consenso informato: è modulare, prestato distintamente per i diversi trattamenti, e reso anche in forma digitale; nella salute mentale i dati sono ultrasensibili, sicché la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi possa accedervi. ↑
099. Conduzione etica della valutazione: gli esiti sono resi pubblici indipendentemente dal loro segno, a garanzia contro la distorsione da selezione dei risultati favorevoli, e l'intero impianto è sottoposto all'approvazione del comitato etico territorialmente competente. ↑
100. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante, senza che ne siano registrate le modalità. ↑
101. Articolo 32 della Costituzione e legge 23 dicembre 1978, n. 833: la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, e il Servizio sanitario nazionale fondato su universalità, eguaglianza ed equità. ↑
102. Articolo 117, terzo comma, della Costituzione: la tutela della salute è materia di competenza concorrente, nella quale allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio e l'organizzazione del servizio; gli atti regionali emiliano-romagnoli operano legittimamente entro tale competenza, sul piano organizzativo. ↑
103. Articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è la leva attraverso cui un'eventuale legge statale potrebbe ricondurre la psicologia di base tra le prestazioni garantite in modo uniforme su tutto il territorio. ↑
104. Corte costituzionale, sentenza 13 dicembre 2021, n. 241: ha riconosciuto legittimo il modello regionale del servizio di psicologia di base, in quanto organizzazione del servizio sanitario che si avvale di professionisti già esistenti; è un precedente di rilievo diretto per l'Emilia-Romagna, che intende strutturare entro la propria

competenza organizzativa una funzione già ampiamente diffusa per via amministrativa e oggetto di proposte di legge. ↑

105. Base giuridica regionale dell'Emilia-Romagna: il percorso delle Case della Salute, avviato nel 2010 con la deliberazione di Giunta n. 291; le linee di indirizzo sulla psicologia clinica e di comunità (deliberazione n. 1141 del 2021) e sull'implementazione della psicologia nelle Case della Comunità (deliberazione n. 2185 del 2023); il progetto di legge n. 8841 del 2024 e la proposta di legge di iniziativa popolare, in corso d'esame. A differenza del Veneto, l'Emilia-Romagna non dispone di un'azienda regionale unica, e la cornice di coordinamento è costituita dalla Regione e dall'Osservatorio regionale previsto dalle proposte di legge. La decisione non verte sul prevedere la funzione, già diffusa, ma sullo strutturarla e dimensionarla. ↑
106. Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2026: le Regioni in piano di rientro non possono utilizzare i fondi del proprio Servizio sanitario per finalità diverse dalla garanzia dei livelli essenziali. L'Emilia-Romagna, con conti prossimi al pareggio e non sottoposta a piano di rientro, non è soggetta a tale vincolo; permane il principio generale di destinazione delle risorse ai livelli essenziali, che la riforma rispetta. ↑
107. Deontologia professionale: il servizio opera nel rispetto delle norme deontologiche della professione, sotto la vigilanza dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, che concorre alla governance e alla formazione. ↑
108. Responsabilità clinica e ruolo dell'IA: l'impiego dell'intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali — il medico di medicina generale resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell'intervento psicologico, e l'IA è assimilata a un dispositivo di supporto, non a una figura che compie atti — sicché non si introduce una nuova figura professionale, ma uno strumento che assiste quelle esistenti. ↑
109. Conformità degli strumenti di IA: il regolamento europeo sull'IA classifica come ad alto rischio i sistemi impiegati nei dispositivi medici; il regolamento sui dispositivi medici impone la marcatura CE; il regolamento sulla protezione dei dati ne disciplina il trattamento; vi si innestano la supervisione umana costante, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias, la trasparenza e il divieto di discriminazione algoritmica. ↑
110. Equità digitale: per non generare nuove disuguaglianze, sono previsti canali tradizionali paralleli per chi non dispone di strumenti digitali — segnatamente le persone anziane delle aree appenniniche — e il supporto multilingue per la popolazione straniera, ferma restando la garanzia dell'alternativa in presenza. ↑
111. Protezione dei dati: misure di sicurezza robuste — crittografia e pseudonimizzazione per le analisi — consenso modulare anche in forma digitale, collaborazione con l'Autorità garante e acquisizione di software dotati di marcatura adeguata secondo le normali procedure. ↑
112. Benchmark statunitense (Collaborative Care): modello a équipe integrata, validato da oltre novanta studi controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri. ↑
113. Esperienze italiane: le sperimentazioni locali, fra cui quelle riconducibili al modello di Solano nel Lazio, anticipano l'integrazione psicologica nelle cure primarie; i dati derivano però da campioni limitati e in parte da letteratura grigia, e vanno assunti con la dovuta cautela. ↑
114. Trasferibilità: i risultati internazionali provengono da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale; la loro trasposizione richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche. ↑
115. Evidenza locale emiliano-romagnola: la regione dispone di una base di evidenza locale di particolare valore, costituita dai progetti aziendali consolidati di psicologia nelle cure primarie — tra cui «Lo Psicologo nella Casa della Salute» dell'AUSL di Bologna, attivo dal 2015, con più di seicento cittadini presi in carico nel

primo triennio, dei quali circa il 70% senza precedente contatto con i servizi di salute mentale — da analizzare e valorizzare sistematicamente nel disegno del servizio strutturato. ↑

116. Condizioni emiliano-romagnole favorevoli alla trasferibilità: la solidità organizzativa del sistema, riconosciuto come benchmark nazionale, la maturità della rete territoriale delle Case della Comunità e l'esperienza dei progetti aziendali costituiscono un terreno particolarmente favorevole all'adozione del modello e alla sua valutazione rigorosa. ↑
117. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative: il rapporto di 4:1 spesso citato e l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio sono semplificazioni a fini divulgativi. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costo complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8:1-5,5:1. ↑
118. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. Per l'Emilia-Romagna, regione a saldo di mobilità attivo tra i più elevati d'Italia e dotata di un sistema sanitario d'eccellenza, riconosciuto come benchmark nazionale, il canale del recupero della mobilità passiva non si applica e i margini di recupero diretto, a fronte di un'elevata appropriatezza di partenza, sono strutturalmente contenuti: il saldo diretto risulta lievemente negativo e il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi. ↑
119. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (7,5%) e non estratti dai conti regionali certificati: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere-Universitarie prima della presentazione esterna. ↑
120. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
121. Valutazione controfattuale d'impatto: i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico; il dispiegamento scaglionato del servizio tra le otto Aziende USL, attivate in tempi diversi sotto il coordinamento della Regione, funge da esperimento naturale e consente di stimare l'effetto causale rendendo le aziende e i distretti non ancora coperti gruppo di confronto. ↑
122. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione, Aziende USL, Aziende Ospedaliere-Universitarie, Istituti di ricovero e cura, Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e università regionali — affiancato dall'Osservatorio regionale previsto dalle proposte di legge in esame, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. A differenza del Veneto, l'Emilia-Romagna non dispone di un'azienda regionale unica e coordina il servizio attraverso la Regione e le otto Aziende USL. ↑
123. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑
124. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. La solida infrastruttura di sanità digitale regionale colloca l'Emilia-Romagna nella posizione di apripista nazionale nella loro adozione. ↑

125. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. ↑
126. ↑
127. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Questa parte copre il settimo dominio del modello HTA, il profilo organizzativo, e fornisce il contenuto del caso commerciale e del caso gestionale del Five Case Model, rispondendo al criterio di sostenibilità. ↑
128. Modello RE-AIM: misura la riuscita e la validità esterna dell'attuazione lungo cinque dimensioni — la portata (quota della popolazione bersaglio raggiunta), l'efficacia (esiti conseguiti), l'adozione (adesione di sedi e professionisti), l'implementazione (fedeltà al modello) e il mantenimento (sostenibilità nel tempo). ↑
129. Quadro consolidato per la ricerca sull'implementazione (CFIR): spiega i determinanti dell'attuazione, articolati in cinque domini — le caratteristiche dell'innovazione, il contesto esterno, il contesto interno, gli individui coinvolti e il processo di attuazione — consentendo l'individuazione ex ante di barriere e facilitatori. ↑
130. Determinanti di implementazione seguiti dallo studio: il tasso di copertura, il grado di adozione delle sedi, la fedeltà al modello, i tempi di attivazione, il numero di psicologi reclutati e formati, la qualità della formazione e della supervisione, il grado di integrazione nei flussi di lavoro, l'aderenza ai percorsi e la scalabilità. ↑
131. Disegno del dispiegamento scaglionato in Emilia-Romagna: le otto Aziende USL passano in sequenza, per fasi semestrali, dalla condizione di controllo a quella di intervento, a partire dalle aziende di maggiore dimensione e prontezza organizzativa, sino a coprire l'intera regione; l'ordine è definito dalla Giunta regionale su criteri trasparenti e reso noto preventivamente, con il coordinamento unitario della Regione. ↑
132. Doppia funzione del dispiegamento scaglionato: esso risponde a un'esigenza organizzativa — attivare il servizio in modo graduale, compatibile con i tempi del reclutamento e della formazione — e al tempo stesso costituisce il fondamento della valutazione controfattuale d'impatto, poiché la successione configura un esperimento naturale, oggetto della Parte L. ↑
133. Reclutamento: a fronte di un fabbisogno a regime dell'ordine di 970 psicologi, il reclutamento avviene tramite l'iscrizione a un elenco istituito presso ciascuna azienda e l'instaurazione di un rapporto convenzionale, con requisiti di iscrizione all'albo e di formazione specifica; in prima applicazione possono accedere i professionisti con pregressa esperienza nell'assistenza psicologica nel Servizio sanitario regionale, valorizzando l'esperienza maturata nei progetti aziendali già attivi, tra cui quelli delle Aziende USL di Bologna, di Modena e della Romagna. ↑
134. Cronoprogramma: l'attivazione procede per fasi semestrali attraverso le otto Aziende USL; le attività di reclutamento, formazione, allestimento e avvio sono condotte in modo scaglionato, azienda per azienda, mentre il monitoraggio e la valutazione accompagnano l'intero arco e proseguono oltre il completamento. ↑
135. Soglia di riuscita del dispiegamento: tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% nella fase di attuazione, a fronte del valore di riferimento del programma inglese; il monitoraggio è chiamato a verificarne il raggiungimento sui dati emiliano-romagnoli. ↑
136. Caso commerciale (Five Case Model): la fattibilità dell'assetto contrattuale poggia sul rapporto convenzionale ancorato all'accordo della specialistica ambulatoriale, da cui un costo medio per incarico dell'ordine di 55.000 euro l'anno e gli scenari di spesa di 27, 40 e 53 milioni già esposti nella Parte E; il

modello dell'elenco aziendale e del rapporto convenzionale è già adottato da altre Regioni e non richiede la creazione di nuove figure. ↑

137. Caso gestionale (Five Case Model): l'attuazione è governata su due livelli. A livello regionale, un comitato di indirizzo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere-Universitarie, gli Istituti di ricovero e cura, l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, la medicina generale, la pediatria di libera scelta e le università regionali, ed è affiancato dall'Osservatorio regionale previsto dalle proposte di legge; a livello aziendale, ciascuna Azienda USL è responsabile dell'attuazione nel proprio ambito, secondo l'indirizzo unitario della Regione. A differenza del Veneto, l'Emilia-Romagna non dispone di un'azienda regionale unica di coordinamento. ↑
138. Rischi attuativi e misure di mitigazione: i rischi principali — reclutamento insufficiente, debole adesione della medicina generale, interoperabilità incompleta dei sistemi informativi, disomogeneità territoriale e venir meno delle coperture — sono associati a misure dedicate; il dispiegamento graduale è esso stesso la principale forma di mitigazione, poiché consente di osservare, correggere e adattare prima dell'estensione. ↑
139. Caso finanziario e coperture (Five Case Model): le fonti di copertura comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, superiore ai dieci miliardi di euro, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'infrastruttura territoriale e digitale, e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali. ↑
140. Vincoli di bilancio: l'Emilia-Romagna dispone di un finanziamento superiore ai dieci miliardi di euro con conti prossimi al pareggio e non è in piano di rientro; il costo del servizio, anche a massima copertura, ne costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale, agevolmente assorbibile, sicché la sostenibilità finanziaria è in Emilia-Romagna più immediata che nelle regioni in difficoltà. ↑
141. Sostenibilità nel tempo (criterio OCSE-DAC): la sostenibilità è assicurata dalla modestia del costo rispetto al bilancio, dal forte ritorno sociale documentato, dall'istituzionalizzazione del servizio — già oggetto di proposte di legge in esame — e dalle economie di scala consentite dal coordinamento regionale e dalla maturità della rete territoriale. ↑
142. Nota di cautela metodologica: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la verifica empirica sui dati emiliano-romagnoli, prevista dalla Parte L, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate. ↑
143. Aspettativa di vita alla nascita dell'ordine degli 83-84 anni, tra le più elevate d'Italia, coerente con il profilo di un sistema sanitario d'eccellenza e con buoni determinanti socio-economici. ↑
144. Componente straniera dell'ordine del 12,6% dei residenti, valore nettamente superiore alla media nazionale e con punte maggiori in alcune province; è motore della crescita demografica e della vitalità economica, ma porta con sé bisogni specifici di salute mentale connessi ai percorsi migratori, all'integrazione e allo stress di adattamento, che richiedono una cura culturalmente competente. ↑
145. Articolazione del territorio in nove province: la sola Bologna supera il milione di abitanti e raccoglie il 22,9% dei residenti, seguita da Modena con il 15,9%; le cinque province dell'Emilia occidentale ospitano oltre due terzi della popolazione, mentre Ferrara e le tre province della Romagna ne accolgono il restante terzo. ↑
146. Profilo per età composito e a marcata variabilità interna: la pianura urbana e produttiva presenta la struttura più dinamica, mentre le aree appenniniche e rurali sono nettamente più anziane e soggette a spopolamento, con maggiore difficoltà di accesso ai servizi. ↑
147. ↑

148. Profilo per età composito e a marcata variabilità interna: la pianura urbana e produttiva presenta la struttura più dinamica, mentre le aree appenniniche e rurali sono nettamente più anziane e soggette a spopolamento, con maggiore difficoltà di accesso ai servizi. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Dipartimenti di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. ↑
149. ↑
150. Profilo per età composito e a marcata variabilità interna: la pianura urbana e produttiva presenta la struttura più dinamica, mentre le aree appenniniche e rurali sono nettamente più anziane e soggette a spopolamento, con maggiore difficoltà di accesso ai servizi. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Dipartimenti di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Identificazione dei costi: il costo del servizio comprende le remunerazioni dei psicologi, i costi organizzativi e di coordinamento e la quota destinata alla formazione congiunta; è stimato per scenario di copertura ed espresso a regime. ↑
151. Costo del servizio per scenario, a regime: dell'ordine di 27 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 40 nello scenario base e 53 nello scenario espansivo, valori coerenti con l'inclusione del programma di formazione all'intelligenza artificiale. ↑
152. Metodo di stima del costo: il valore unitario per incarico è dell'ordine di 55.000 euro annui; la stima è regionalizzata in proporzione alla popolazione e al numero di professionisti, con economie di scala consentite dal coordinamento regionale e dalla maturità della rete territoriale. ↑
153. Identificazione e misura degli esiti: gli esiti di salute sono espressi in anni di vita ponderati per la qualità e in esiti clinici validati; i tassi di recupero e di miglioramento sono desunti dai benchmark consolidati e applicati in via prudenziale. ↑
154. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi (questionario a nove voci sui sintomi depressivi e scala a sette voci per il disturbo d'ansia); tasso di recupero di riferimento dell'ordine del 50%. ↑
155. Costo-efficacia e costo-utilità: il costo per anno di vita ponderato per la qualità si colloca al di sotto della soglia comunemente adottata; l'analisi per paziente, sviluppata nella Parte F, indica condizioni di dominanza dell'intervento rispetto all'opzione di non intervento. ↑
156. Soglia di costo-efficacia di riferimento dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, coerente con la prassi internazionale della valutazione economica in sanità. ↑
157. ↑
158. Soglia di costo-efficacia di riferimento dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, coerente con la prassi internazionale della valutazione economica in sanità. Questa parte organizza la misurazione dell'intervento nel tempo: serve ex post i criteri della griglia di giudizio, chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione e fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti. ↑
159. Modello di Donabedian per la qualità dell'assistenza: distingue le dimensioni di struttura, processo ed esito, qui integrate dalla dimensione dell'impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società. ↑
160. Batteria di indicatori: circa cinquantotto misure articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti e circa quaranta richiedono la rilevazione diretta del servizio. ↑

161. Set di esiti essenziali: l'iniziativa COMET e gli standard ICHOM individuano, mediante consenso strutturato (metodo Delphi), un nucleo parsimonioso di esiti da misurare, evitando la proliferazione di misure ridondanti. ↑
162. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline: bisogno e domanda (disponibile), accesso ed equità (da rilevare), processo (da rilevare), esito clinico (da rilevare), economici (misto), impatto sociale (misto), organizzativi (da rilevare), variabili di sintesi (da calcolare); i divari tra Aziende USL sono tra le misure di equità. ↑
163. Protocollo minimo di rilevazione: attivo dal primo giorno, registra la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni, deliberatamente essenziale per non gravare sull'attività clinica. ↑
164. Strumenti di esito: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9), con punteggio totale da 0 a 27, soglia di rilevanza clinica intorno a 10 e cambiamento affidabile dell'ordine di 6 punti, e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7), impiegati nei soli punteggi complessivi. ↑
165. Modello di misurazione dei programmi inglesi di terapie psicologiche: la raccolta delle misure di esito a ogni seduta, e non solo all'inizio e alla fine, consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non protrarre percorsi inefficaci. ↑
166. Costituzione della baseline su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti — demografici, epidemiologici, di benessere, di mortalità — forniscono la fotografia del prima e vanno registrati subito; la rilevazione di servizio parte con il primo assistito. Ogni mese di ritardo nell'avvio è un mese di dati di base perduti. ↑
167. Calendario della rilevazione: prima dell'avvio, costituzione della baseline con i dati disponibili e predisposizione del registro e dei questionari; all'avvio, inizio della registrazione; in continuo, trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale con cadenza mensile; periodicamente, calcolo delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale. ↑
168. Valutazione controfattuale d'impatto: misura l'effetto causale dell'intervento confrontando gli esiti dei trattati con il controfattuale, ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente; lo strumento che la rende possibile è il disegno scaglionato del dispiegamento, idoneo esperimento naturale. ↑
169. Differenza-nelle-differenze: confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le Aziende USL già attivate e quelle non ancora attivate, sotto l'ipotesi di andamento parallelo; vi si affianca il controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata di unità non trattate. ↑
170. Effetti stimati e validità: l'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e l'effetto medio sui soli trattati; i disegni a esperimento naturale sono, per gli interventi di salute della popolazione, lo strumento raccomandato dalla letteratura metodologica; la validità esterna va valutata a parte. ↑
171. Trasformazione delle stime in prove: confrontando l'andamento, ad esempio, degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche nelle Aziende che hanno attivato il servizio con quello delle Aziende che lo attiveranno, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata sui dati emiliano-romagnoli. ↑
172. Verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (VIR; DPCM 169/2017): è valutazione ex post, di norma dopo un biennio, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, che chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva. ↑
173. Clausola valutativa: sul piano regionale, impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti; è il passaggio che lega la misurazione tecnica alla responsabilità politica e alla trasparenza verso il legislatore regionale. ↑

174. Manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi (2008): articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione delle variabili alla normalizzazione, alla ponderazione e all'analisi di robustezza. ↑
175. Benessere Equo e Sostenibile (BES), ISTAT: dodici domini con indici compositi; con la legge n. 163/2016 di riforma del bilancio, una selezione di indicatori è entrata nel ciclo della programmazione economica, a precedente istituzionale dell'impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica. ↑
176. Regole di coerenza e di non duplicazione: il divieto di doppia contabilizzazione impone che, nel medesimo calcolo, una grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali già adottata nella Parte E. ↑
177. Risparmi diretti complessivi per il Servizio sanitario regionale stimati nell'ordine di 16 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 27 nello scenario base e 40 nello scenario espansivo, collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa dell'intervallo in ragione dell'elevata efficienza e appropriatezza del sistema regionale. ↑
178. Saldo diretto per il bilancio sanitario, dato dalla differenza tra risparmi diretti e costo del servizio, dell'ordine di -11, -13 e -13 milioni di euro annui nei tre scenari: è lievemente negativo, coerentemente con la natura di regione creditrice e con l'elevata appropriatezza del sistema emiliano-romagnolo, in cui i margini di recupero diretto sono strutturalmente contenuti. ↑
179. Il saldo diretto negativo è dichiarato senza attenuazioni e non costituisce una debolezza dell'analisi, ma il suo profilo onesto: a differenza della Puglia, dove il recupero della mobilità passiva concorre al pareggio diretto, in Emilia-Romagna — come in Lombardia e in Veneto — il valore dell'intervento risiede in misura preponderante nelle ricadute economico-sociali, ed è questa la chiave di lettura del caso economico. ↑
180. Ritorno sociale: le ricadute economico-sociali comprendono il valore della maggiore produttività recuperata, la riduzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, le efficienze nel sistema dei servizi di salute mentale e il sollievo alle figure di cura familiari. In un'economia dinamica, a forte tessuto manifatturiero e a elevata occupazione, la componente della produttività recuperata è la voce di maggior peso del beneficio complessivo. ↑
181. Ricadute economico-sociali stimate nell'ordine di 86 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 160 nello scenario base e 250 nello scenario espansivo, secondo i metodi del ritorno sociale sull'investimento, con criteri di stima conservativi. ↑
182. Ritorno complessivo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali, dell'ordine di 102, 187 e 290 milioni di euro annui nei tre scenari; il saldo complessivo, al netto del costo del servizio, è dell'ordine di +75, +147 e +237 milioni di euro annui. ↑
183. Rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,8:1 nello scenario conservativo, 4,7:1 nello scenario base e 5,5:1 nello scenario espansivo, in linea con il valore validato sulle altre regioni e coerente con le stime metodologicamente fondate della letteratura. ↑
184. Caso economico e caso finanziario secondo il Five Case Model: il caso finanziario, riferito al solo bilancio sanitario, presenta un saldo diretto lievemente negativo; il caso economico, riferito alla collettività, è ampiamente positivo. La distinzione tra le due grandezze è la chiave dell'analisi. ↑
185. Sostenibilità finanziaria: il costo del servizio si colloca nell'ordine dello 0,3-0,5% di un Fondo Sanitario Regionale superiore ai dieci miliardi di euro, importo pienamente sostenibile per un sistema solido e prossimo al pareggio, e ulteriormente ottimizzabile grazie alle economie di scala consentite dal coordinamento regionale e dalla maturità della rete territoriale. ↑

186. Lacuna prioritaria: le grandezze economiche qui impiegate sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione (7,5%) e non estratte dai conti regionali certificati; la loro verifica presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliero-Universitarie è condizione per la presentazione alle autorità di finanza pubblica. ↑
187. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 890.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato dall'offerta strutturata attuale. ↑
188. Modello organizzativo: lo psicologo di base opera nelle Case della Comunità e nei Nuclei delle Cure Primarie, in collaborazione con i medici di medicina generale, secondo protocolli condivisi; il coordinamento, l'omogeneità attuativa e le economie di scala sono assicurati dalla Regione e dall'Osservatorio regionale previsto dalle proposte di legge in esame, che operano sulle otto Aziende USL. A differenza del Veneto, l'Emilia-Romagna non dispone di un'azienda regionale unica, e la sua rete territoriale matura costituisce l'infrastruttura su cui il modello si innesta senza nuove strutture. ↑
189. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
190. Percorso clinico: accesso su invio del medico di medicina generale, nella forma già sperimentata della Consultazione Psicologica Primaria, o accesso diretto; valutazione iniziale; ciclo di colloqui brevi; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. ↑
191. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
192. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
193. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
194. ↑
195. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). Questa parte conclusiva applica la griglia di giudizio del telaio, i criteri dell'OCSE-DAC, che attraversano l'intero studio come metro di valutazione e convergono qui nella sintesi; fornisce inoltre il contenuto del caso strategico del Five Case Model. ↑
196. Criteri di valutazione dell'OCSE-DAC (rivisti nel 2019, «Better Criteria for Better Evaluation»): sei lenti complementari — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità — che insieme danno un quadro complessivo dell'intervento. ↑
197. Rilevanza: l'intervento risponde a un bisogno reale e di grande dimensione — dell'ordine di 890.000 persone con disagio comune in larga parte inevaso — e all'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza. ↑
198. Coerenza: l'intervento è compatibile e complementare con gli standard dell'assistenza territoriale (DM 77/2022), con la Missione 6 del PNRR e con gli atti regionali che già ne prevedono la funzione — le deliberazioni di Giunta del 2021 e del 2023 e i progetti aziendali consolidati — ed è costituzionalmente difendibile; l'Emilia-Romagna, non sottoposta a piano di rientro e con bilancio sanitario in progressivo riequilibrio, non incontra il vincolo che grava sulle regioni in disavanzo strutturale. ↑

199. Efficacia: l'evidenza internazionale documenta che i modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie raggiungono gli obiettivi clinici, con tassi di recupero dell'ordine del 50% nel programma inglese. ↑
200. Efficienza: l'intervento è favorevole in termini di costo-utilità — con dominanza per paziente e costo-efficacia confermata dall'analisi probabilistica — a fronte, per l'Emilia-Romagna, di un saldo diretto negativo sul solo bilancio sanitario, di entità modesta rispetto a un finanziamento dell'ordine di dieci miliardi; l'efficienza allocativa è dunque elevata, la convenienza per il solo bilancio negativa. ↑
201. Impatto: l'impatto distributivo è favorevole, poiché i benefici si concentrano dove l'accesso è più difficile — le aree dell'Appennino, i cittadini stranieri e le popolazioni gravate dalle liste di attesa — riducendo il gradiente territoriale; il ritorno complessivo è dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. ↑
202. Sostenibilità: l'intervento è finanziariamente sostenibile — a fronte di un costo modesto, di una pluralità di coperture e di un bilancio regionale in progressivo riequilibrio — e organizzativamente, in quanto inseribile senza nuove strutture nella rete territoriale già matura delle Case della Comunità e delle Case della Salute. ↑
203. Analisi multi-criterio (buone pratiche ISPOR): rende esplicito il bilanciamento dei criteri non riducibili a denaro — l'equità, la fattibilità, la coerenza strategica, la robustezza dell'evidenza — attribuendo a ciascuno un peso e a ciascuna opzione un punteggio. ↑
204. Risultato dell'analisi multi-criterio: su otto criteri pesati, l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 81,45 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri tranne la fattibilità immediata; il risultato è stabile rispetto ai pesi adottati. ↑
205. Le tre affermazioni del cruscotto decisionale per l'Emilia-Romagna: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, trascurabile rispetto a un finanziamento dell'ordine di dieci miliardi; il ritorno per la collettività è ampio (rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno); il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali. ↑
206. Raccomandazione centrale: la decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già diffusa in numerose Aziende USL attraverso atti amministrativi regionali e progetti aziendali consolidati — ma se strutturarla, dimensionarla e istituzionalizzarla, portandola dalla diffusione amministrativa frammentaria alla copertura sistematica del fabbisogno, dell'ordine di 730 incarichi. ↑
207. Cruscotto secondo il Quintuple Aim: la sintesi del valore è letta lungo le cinque dimensioni dell'esito di salute, dell'esperienza, del costo, del benessere degli operatori e dell'equità. ↑
208. Limite principale (radicamento nei dati): le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione emiliano-romagnola (7,5%), e non estratte dai conti regionali certificati; tale sostituzione è la condizione per la presentazione agli organi di controllo. ↑
209. Cautele di trasferibilità e di fonte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la cifra del ritorno è prudenziale e non ponderata per l'equità. ↑
210. Agenda di ricerca: l'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere-Universitarie, seguito dall'avvio della rilevazione di servizio e dalla valutazione controfattuale sul dispiegamento scaglionato. ↑
211. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale, e va prevista fin dall'avvio del servizio. ↑
212. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑

213. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
214. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
215. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: in Emilia-Romagna sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle aree appenniniche, più anziane e soggette a spopolamento; sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza. ↑
216. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
217. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso le Università di Bologna, di Modena e Reggio Emilia, di Parma e di Ferrara); post-universitario specialistico (corso regionale con attestato sulla psicologia di base e le cure primarie, comprensivo della competenza culturale per la popolazione straniera); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). ↑
218. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La solida infrastruttura di sanità digitale regionale candida l'Emilia-Romagna a contesto esemplare e apripista a livello nazionale per l'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. ↑
219. ↑
220. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La solida infrastruttura di sanità digitale regionale candida l'Emilia-Romagna a contesto esemplare e apripista a livello nazionale per l'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. Questa parte sviluppa i metodi di modellazione e di gestione dell'incertezza del quinto dominio, secondo le buone pratiche di ricerca sulla modellazione dell'ISPOR e dell'Accademia delle scienze, ed è riportata secondo lo standard CHEERS 2022. ↑
221. Modello di Markov a coorte, strumento standard della valutazione economica in sanità: rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi (sintomatico, recupero, cronico, morte), scanditi da cicli con correzione di metà ciclo; la microsimulazione ne costituisce la variante per le traiettorie individuali. ↑
222. Risultati del caso base (singolo paziente, orizzonte di cinque anni, valori scontati): il braccio dell'intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un'utilità di 3,627 anni di vita ponderati, contro un costo di circa 3.799 euro e un'utilità di 3,392 dell'assistenza usuale; l'intervento è quindi meno costoso (di circa 1.304 euro) e più efficace (di circa 0,236 anni), configurando una dominanza. ↑
223. La dominanza si spiega con la struttura del modello: a fronte di un costo iniziale contenuto, l'intervento accresce il tempo trascorso nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce il tempo trascorso nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte. Il risultato per paziente è il fondamento microeconomico delle stime aggregate della Parte E ed è indipendente dalla regione. ↑
224. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. ↑
225. ↑

226. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudenziale per l'ottimismo delle stime. ↑
227. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
228. Quadro economico consolidato per l'Emilia-Romagna (Parte E): a regime, da circa 490 a circa 960 psicologi, costo del servizio di 27-53 milioni, risparmi diretti di 16-40 milioni, ricadute sociali di 86-250 milioni; il saldo diretto è negativo, il saldo complessivo positivo, con rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno. ↑
229. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
230. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio. ↑
231. Valori regionali di ancoraggio per l'Emilia-Romagna: popolazione di 4.451.938 abitanti (Censimento ISTAT 2024) in crescita, finanziamento del Servizio sanitario regionale superiore a 10 miliardi di euro con disavanzo in riduzione e nessun piano di rientro, saldo di mobilità fortemente attivo, fabbisogno a regime fino a circa 960 psicologi nello scenario espansivo. ↑
232. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione emiliano-romagnola (7,5%), e non estratti dai conti regionali certificati; i dati da acquisire presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere-Universitarie sono elencati nella tabella seguente. ↑
233. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑
234. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni agli studi pugliese, lombardo e veneto, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑
235. Analisi di sensibilità a una via: ciascun parametro è fatto variare del 25% in più e in meno, misurandone l'effetto sul beneficio monetario netto; il diagramma a tornado ordina i parametri per influenza, con l'efficacia clinica, i tassi di ricaduta e di cronicizzazione e il costo dello stato cronico tra i più influenti. ↑
236. Incertezza strutturale: oltre all'incertezza dei parametri, l'incertezza sulla struttura e sulle assunzioni del modello è trattata mediante analisi di scenario, e i risultati sono riportati secondo lo standard CHEERS, con validazione della coerenza interna ed esterna. ↑
237. Analisi di sensibilità probabilistica: il modello è eseguito diecimila volte con estrazione casuale dei parametri dalle rispettive distribuzioni (simulazione Monte Carlo), propagando l'incertezza dei parametri sull'incertezza del risultato. ↑
238. Soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, valore di riferimento nella prassi italiana e internazionale. ↑

239. Curva di accettabilità della costo-efficacia: alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è dell'88,9% e la probabilità che sia dominante dell'84,6%; il beneficio monetario netto medio sulle diecimila iterazioni è di circa 7.815 euro per paziente, con intervallo di credibilità al 95% da circa -5.736 a circa +21.501 euro. ↑
240. Distinzione tra costo-utilità e impatto sul bilancio per l'Emilia-Romagna: la probabilità di costo-efficacia è un risultato di efficienza, riferito al singolo paziente, che valorizza il guadagno di salute e l'intera traiettoria di costo del modello; esso è coerente con il saldo diretto aggregato della Parte E, che per l'Emilia-Romagna è negativo, poiché la traduzione dal modello per paziente all'aggregato regionale incorpora le correzioni per peso morto e per l'effettiva monetizzabilità nel bilancio dei costi evitati, e poiché manca il canale della mobilità, essendo l'Emilia-Romagna regione creditrice. L'efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali. ↑
241. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. ↑
242. ↑
243. Posizione della Toscana: la Regione è fra le poche in Italia a essersi dotata di una legge regionale dedicata, la legge regionale 15 novembre 2022, n. 39, recante disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base, con regolamento di attuazione approvato con deliberazione della Giunta regionale 43 del 22 gennaio 2024, a sua volta fondato sulla decisione dell'Organismo Toscano di Governo Clinico n. 17 del 15 giugno 2023, contenente gli indirizzi operativi. Sulla base di tale cornice è stata avviata, dal settembre 2024, una sperimentazione del servizio nelle Case della Comunità e nelle Case della Salute, in integrazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, gratuita e senza compartecipazione alla spesa. ↑
244. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. ↑
245. Priorità di acquisizione: i parametri ancora ricostruiti per quota di popolazione — segnatamente quelli dei canali dei ricoveri, della specialistica e del pronto soccorso — sono quelli su cui il valore dell'informazione è più elevato e verso i quali si indirizza prioritariamente la richiesta di dati certificati alle tre Aziende USL e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie; la Toscana dispone inoltre dei propri dati di esito della sperimentazione attiva, da consolidare come fonte primaria di calibrazione. ↑
246. Verifica empirica: poiché il servizio è già attivo in via sperimentale, la verifica non poggia su un dispiegamento scaglionato a partire da zero, ma sul confronto prima-dopo l'attivazione del settembre 2024 e sull'estensione progressiva tra le strutture e le zone, oggetto della Parte L, che configura un disegno quasi a cunei progressivi e riduce l'incertezza sostituendo le stime con misure osservate sui dati toscani. ↑
247. Disagio giovanile: è una componente rilevante e in crescita, con fenomeni di ansia e disagio tra gli adolescenti che solo in parte trovano risposta nei servizi; la quota intercettata rappresenta presumibilmente una frazione del bisogno reale. ↑
248. Salute mentale connessa al lavoro: nella popolazione attiva, ampia parte dei lavoratori è esposta a fattori di stress correlati al lavoro; l'intercettazione precoce del disagio ha un valore particolarmente elevato in termini di produttività recuperata. ↑
249. Bisogno dell'età anziana: la domanda connessa all'invecchiamento, alla cronicità e alla comorbidità psicologica delle patologie croniche è il tratto più caratteristico del fabbisogno toscano, in una delle regioni più anziane d'Italia, accentuato nelle aree interne e montane, più anziane e a maggiore difficoltà di accesso.

↑

250. Tratto distintivo della Toscana rispetto alle altre regioni: la combinazione di un invecchiamento tra i più marcati d'Italia, con ampie aree interne e montane, di una dimensione multiculturale rilevante e della condizione di Regione che ha già istituito il servizio con una legge dedicata e ne ha avviato la sperimentazione, producendo numeri verificabili; il bisogno è quindi accompagnato sia da una base giuridica già acquisita sia da un'esperienza operativa concreta da portare a regime. ↑
251. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche stimati nell'ordine di 30.000 l'anno, per proiezione dai circa 479.000 accessi psichiatrici nazionali rilevati nel 2021 (pari al 3,3% del totale); una quota è riconducibile a disagio comune non intercettato a monte. ↑
252. Offerta territoriale: la Toscana ha istituito il servizio di psicologia di base con la legge regionale 39 del 2022 e ne ha avviato la sperimentazione dal settembre 2024, articolandola progressivamente nelle Case della Comunità e nelle Case della Salute, in integrazione con la medicina generale e gratuita per il cittadino. Nei primi diciotto mesi circa 2.300 cittadini hanno avviato un percorso — dell'ordine di mille nell'Azienda USL Toscana Centro, oltre ottocento nella Sud Est e quasi cinquecento nella Nord Ovest. Il servizio opera però su base libero-professionale, in ventuno strutture, e copre una frazione ridotta del fabbisogno. ↑
253. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 790 psicologi (intervallo 750-820). L'Ordine degli Psicologi della Toscana, che ha accompagnato l'attivazione del servizio con un proprio rappresentante nel gruppo di lavoro regionale, ne sostiene la strutturazione a regime con un rapporto stabile, a superamento degli incarichi libero-professionali della fase sperimentale. ↑
254. Copertura attuale del fabbisogno ridotta: il servizio è attivo in via sperimentale ma dimensionato a una frazione del bisogno potenziale, dell'ordine del cinque per cento; i numeri della sperimentazione — circa 2.300 cittadini in diciotto mesi — dimostrano la capacità di intercettazione del modello, ma anche la distanza dalla copertura del fabbisogno. ↑
255. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante in Toscana si articola su più assi — la dualità fra l'area metropolitana centrale, lungo l'asse Firenze-Prato-Pisa, e le aree interne e montane, anziane e in spopolamento, dove l'accesso è strutturalmente più difficoltoso; la dimensione multiculturale, con la necessità di competenza culturale soprattutto nell'area pratese; e la pressione delle liste di attesa. La telepsicologia assistita è lo strumento per avvicinare l'offerta alle aree interne, e la sperimentazione ha già mostrato adesione anche nei piccoli centri e nelle zone montane. ↑
256. Finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 8 miliardi di euro; la Toscana non è soggetta a un piano di rientro, ma opera, come gran parte delle regioni, sotto pressione finanziaria, con la riduzione delle liste di attesa indicata come priorità. Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2024-2026 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 67 del 30 luglio 2025. ↑
257. Mobilità sanitaria a saldo nettamente attivo, dell'ordine di 58 milioni di euro nel 2023, che colloca la Toscana tra le regioni più attrattive d'Italia, dopo Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; l'attrazione è trainata dalle grandi Aziende Ospedaliero-Universitarie — Careggi, Pisana, Senese — in specialità quali la gastroenterologia, l'oculistica, l'ortopedia e la neurologia. Poiché la regione è già creditrice, il canale del recupero della mobilità, centrale per le regioni debitrice del Mezzogiorno, non costituisce qui una leva di risparmio. ↑
258. Cornice normativa e programmatica: la Toscana dispone di una legge regionale dedicata, la legge 39 del 2022, attuata con il regolamento di cui alla deliberazione 43 del 22 gennaio 2024 e fondata sugli indirizzi operativi dell'Organismo Toscano di Governo Clinico (decisione 17 del 2023); con la deliberazione 1601 del 2023 sono stati fissati criteri e requisiti, e con la deliberazione 244 del 2025 la sperimentazione è stata estesa a tutte e tre le Aziende USL e prorogata. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard

dell'assistenza territoriale; sul piano nazionale, il testo unificato C. 1140, il Piano Nazionale per la Salute Mentale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 sulla competenza regionale. A differenza di altre regioni, in Toscana una legge regionale dedicata è già vigente. [↑](#)

259. Popolazione residente in Toscana 3.657.716 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 6,2% della popolazione nazionale, in lieve calo rispetto all'anno precedente; la popolazione è segnata da un marcato invecchiamento e da bassa natalità, con proiezioni che indicano una perdita dell'ordine del quattro per cento dei residenti al 2040 e del dodici per cento al 2060. Circa la metà della popolazione risiede nelle province di Firenze, Pisa e Lucca, lungo l'asse urbano centrale che congiunge Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli; il restante è distribuito tra le altre sette province, con una quota significativa in aree interne e montane. [↑](#)

260. [↑](#)

261. Popolazione residente in Toscana 3.657.716 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 6,2% della popolazione nazionale, in lieve calo rispetto all'anno precedente; la popolazione è segnata da un marcato invecchiamento e da bassa natalità, con proiezioni che indicano una perdita dell'ordine del quattro per cento dei residenti al 2040 e del dodici per cento al 2060. Circa la metà della popolazione risiede nelle province di Firenze, Pisa e Lucca, lungo l'asse urbano centrale che congiunge Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli; il restante è distribuito tra le altre sette province, con una quota significativa in aree interne e montane. Questa parte copre l'ottavo dominio del modello HTA, il profilo del paziente e sociale, e risponde al criterio di impatto della griglia di giudizio; l'equità è trattata come dimensione costitutiva della valutazione, secondo l'evoluzione che ha affiancato l'equità in salute agli obiettivi di esito, esperienza e costo. [↑](#)

262. Gradiente sociale della salute mentale: le popolazioni in deprivazione presentano prevalenze più elevate di disturbi mentali comuni e un accesso più difficile ai servizi. In Toscana il rischio di povertà o esclusione è contenuto in aggregato, sicché il gradiente socio-economico non è il tratto distintivo dell'equità; prevalgono tre dimensioni diverse: la dualità fra l'area metropolitana centrale e le aree interne e montane, anziane e in spopolamento; l'invecchiamento della popolazione, tra i più marcati d'Italia; e una rilevante dimensione multiculturale, che richiede competenza culturale soprattutto nell'area pratese. [↑](#)

263. La gratuità, la prossimità e l'assenza di stigma del servizio di primo livello abbattano le barriere economiche, geografiche e culturali che gravano in misura maggiore sulle popolazioni svantaggiate; in Toscana rilevano in particolare l'abbattimento della barriera geografica nelle aree interne e montane — come l'Amiata, la Garfagnana e la Lunigiana — dove la distanza dai servizi è il principale ostacolo, integrato dalla telepsicologia, e l'abbattimento della barriera culturale e linguistica per l'utenza straniera. [↑](#)

264. Variabili di equità, accesso e protezione finanziaria seguite dallo studio: riduzione dei tempi di attesa per l'accesso psicologico, accessibilità geografica nelle aree interne e montane, accessibilità culturale e linguistica, equità di esito tra gruppi, equità di genere, accesso per l'età anziana, per i gruppi fragili e le persone con disabilità, gratuità per i gruppi vulnerabili, copertura del bisogno non soddisfatto. [↑](#)

265. Analisi costo-efficacia distributiva (DCEA), secondo Cookson, Asaria e colleghi: estende la valutazione economica alla dimensione dell'equità, stimando come costi ed esiti si distribuiscano tra i sottogruppi e quale ne sia l'effetto sulle disuguaglianze, mediante anni di vita ponderati per l'equità, indice di concentrazione e indici di disuguaglianza assoluta e relativa. [↑](#)

266. Direzione del risultato distributivo: poiché il guadagno di accesso è più ampio dove l'accesso è oggi più difficile — le aree interne e montane, l'età anziana, l'utenza straniera e i gruppi gravati dalle liste di attesa — i benefici dell'intervento si concentrano sui gruppi più svantaggiati nell'accesso, riducendo il gradiente territoriale negli esiti di salute mentale; l'intervento migliora l'esito medio e ne comprime al tempo stesso la disuguaglianza. [↑](#)

267. Ponderazione distributiva: l'attribuzione di pesi maggiori ai benefici che ricadono sui più svantaggiati accrescerebbe il valore sociale stimato; lo studio adotta tuttavia, come riferimento conservativo, il rapporto beneficio-costi non ponderato già esposto nella Parte E, dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. In Toscana, ove la popolazione non è prevalentemente deprivata, l'effetto della ponderazione sarebbe più contenuto che nel Mezzogiorno, il che rende la scelta non ponderata tanto più prudente. ↑
268. Algoritmo allocativo quale meccanismo operativo dell'equità: la distribuzione territoriale degli incarichi non segue la sola popolazione, ma pondera ciascuna zona-distretto per l'indice di vecchiaia, l'indice di deprivazione socioeconomica, la prevalenza di cronicità e multimorbidità e la presenza straniera, attribuendo pesi maggiori alle aree interne e montane e anziane e alle aree a forte presenza multiculturale; in Toscana l'indice di vecchiaia è il fattore di ponderazione di maggior peso, affiancato dalla presenza straniera nell'area centrale. ↑
269. Indice di deprivazione multipla: misura sintetica costruita su reddito, occupazione, istruzione, salute, condizione abitativa e ambiente, impiegata per individuare le aree prioritarie nell'allocazione degli incarichi. ↑
270. Divari territoriali in Toscana: il divario rilevante non è quello Nord-Sud, ma quello interno tra l'area metropolitana centrale, lungo l'asse Firenze-Prato-Pisa, densa e ben servita, e le aree interne e montane, a popolazione anziana e dispersa e in spopolamento. In queste aree la sola presenza fisica di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio, integrato dalla telepsicologia; la sperimentazione ha già mostrato adesione anche nei piccoli centri e nelle zone montane. ↑
271. Liste di attesa, uniformità del servizio e aree interne quali dimensioni di equità: in Toscana, dove il canale della mobilità recuperata è inapplicabile perché la regione è creditrice, le principali leve distributive sono la riduzione delle liste di attesa, che oggi penalizzano chi non può ricorrere al privato, l'estensione uniforme del servizio dalla sperimentazione in ventuno strutture a tutte le Case della Comunità delle tre Aziende USL, e l'accesso nelle aree interne e montane. ↑
272. Protezione finanziaria: il servizio pubblico e gratuito riduce la spesa privata diretta per la psicoterapia, l'impovertimento connesso alle cure e le spese sanitarie catastrofiche, con beneficio maggiore per i redditi bassi, per i quali la psicoterapia privata è spesso inaccessibile. ↑
273. Copertura del bisogno non soddisfatto come equità: intercettare la quota inevasa del disagio — dell'ordine di 730.000 persone, in larga parte non intercettata — significa raggiungere proprio coloro che hanno minore probabilità di accedere spontaneamente ai servizi. ↑
274. Collegamento al monitoraggio: gli indicatori di equità — accesso per area e per livello socio-economico, accesso dell'età anziana e dell'utenza straniera, gradiente dell'esito, tempi di attesa per area — fanno parte del sistema di indicatori della Parte L, e consentono di accertare nel tempo se il servizio raggiunga le comunità interne e montane più distanti e i gruppi più fragili. ↑
275. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; servizio attuale come comparatore. ↑
276. ↑
277. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; servizio attuale come comparatore. Metodo della revisione: la sintesi delle prove segue i criteri di

rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche (PRISMA 2020) e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE; sono considerati studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. ↑

278. Studio fondativo del modello collaborativo (IMPACT), pubblicato su JAMA nel 2002: circa il 50% dei pazienti trattati ha conseguito una riduzione di almeno il 50% dei sintomi a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. ↑
279. Meta-analisi su cinquantasette studi controllati (2012): l'integrazione della cura ha prodotto un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard rispetto alla cura usuale. ↑
280. Revisione di quarantadue implementazioni del modello (2024): riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 43% dell'ansia a sei mesi, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. ↑
281. Programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies), dati reali 2023-2024: tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile del 67,8% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su una scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno. ↑
282. Meta-analisi sulle cure integrate: coefficiente standardizzato dell'ordine di -0,11 sui sintomi depressivi, di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante quando applicato a una popolazione ampia. ↑
283. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. ↑
284. Cautela metodologica rilevante: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi (l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero); il valore economico del modello poggia in misura preponderante sui ritorni sociali, non sui risparmi sanitari diretti. Questa cautela è coerente con il profilo del caso economico toscano, fondato anch'esso sulle ricadute sociali. ↑
285. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. ↑
286. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. ↑
287. ↑
288. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. Questa parte copre tre domini del modello HTA — il profilo etico (dominio 6), il profilo organizzativo (dominio 7) e il profilo giuridico (dominio 9) — che completano la valutazione oltre i piani già trattati. ↑
289. Profilo etico: le dimensioni rilevanti sono l'equità di accesso, l'autonomia della persona e la tutela del consenso informato; la persona resta il soggetto, e mai l'oggetto, della presa in carico. ↑
290. Consenso informato: è modulare, prestato distintamente per i diversi trattamenti, e reso anche in forma digitale; nella salute mentale i dati sono ultrasensibili, sicché la persona deve sapere con chiarezza se interagisce con un sistema di intelligenza artificiale, quali dati siano raccolti e chi possa accedervi. ↑
291. Conduzione etica della valutazione: gli esiti sono resi pubblici indipendentemente dal loro segno, a garanzia contro la distorsione da selezione dei risultati favorevoli, e l'intero impianto è sottoposto all'approvazione del comitato etico territorialmente competente. ↑

292. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e, ove necessario, ai percorsi dell'emergenza, in raccordo con il medico curante, senza che ne siano registrate le modalità. ↑
293. Articolo 32 della Costituzione e legge 23 dicembre 1978, n. 833: la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, e il Servizio sanitario nazionale fondato su universalità, eguaglianza ed equità. ↑
294. Articolo 117, terzo comma, della Costituzione: la tutela della salute è materia di competenza concorrente, nella quale allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio e l'organizzazione del servizio; la Toscana ha esercitato tale competenza nella forma più piena, approvando una legge regionale dedicata che istituisce il servizio, e non con un mero atto amministrativo. ↑
295. Articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è la leva attraverso cui un'eventuale legge statale potrebbe ricondurre la psicologia di base tra le prestazioni garantite in modo uniforme su tutto il territorio. ↑
296. Corte costituzionale, sentenza 13 dicembre 2021, n. 241: ha riconosciuto legittimo il modello regionale del servizio di psicologia di base, in quanto organizzazione del servizio sanitario che si avvale di professionisti già esistenti; è un precedente che conforta in modo specifico la scelta della Toscana, la quale ha consolidato proprio quel modello in una legge regionale dedicata. ↑
297. Base giuridica regionale della Toscana: il servizio è istituito dalla legge regionale 15 novembre 2022, n. 39, attuata con il regolamento di cui alla deliberazione 43 del 22 gennaio 2024 e fondata sugli indirizzi operativi dell'Organismo Toscano di Governo Clinico; con successive deliberazioni la sperimentazione è stata avviata, estesa a tutte e tre le Aziende USL e prorogata. A differenza del Veneto, la Toscana non dispone di un'azienda regionale unica, e la cornice di coordinamento è costituita dalla Regione, dalle tre Aziende USL e dall'organismo di governo clinico. La decisione non verte sul prevedere la funzione né sul dotarla di una legge, già esistente, ma sul portarla dalla sperimentazione alla strutturazione a regime e sul dimensionarla. ↑
298. Vincolo di destinazione delle risorse: il principio per cui i fondi del Servizio sanitario devono essere destinati alla garanzia dei livelli essenziali è rispettato dalla riforma, di costo contenuto e relativa a un servizio di primo livello delle cure primarie. La Toscana non è sottoposta a piano di rientro ed è regione creditrice nella mobilità, ma opera sotto pressione finanziaria; l'investimento incrementale necessario alla strutturazione a regime è coerente con tale principio. ↑
299. Deontologia professionale: il servizio opera nel rispetto delle norme deontologiche della professione, sotto la vigilanza dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, che ha accompagnato l'attivazione del servizio con un proprio rappresentante nel gruppo di lavoro regionale e concorre alla governance e alla formazione. ↑
300. Responsabilità clinica e ruolo dell'IA: l'impiego dell'intelligenza artificiale non altera le responsabilità professionali — il medico di medicina generale resta garante della diagnosi e della terapia medica, lo psicologo dell'intervento psicologico, e l'IA è assimilata a un dispositivo di supporto, non a una figura che compie atti — sicché non si introduce una nuova figura professionale, ma uno strumento che assiste quelle esistenti. ↑
301. Conformità degli strumenti di IA: il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, in vigore dal 2025, classifica come ad alto rischio i sistemi impiegati nei dispositivi medici, con obblighi differiti oltre il 2027; il regolamento sui dispositivi medici impone la marcatura CE; il regolamento sulla protezione dei dati ne disciplina il trattamento; vi si innestano la supervisione umana costante, la validazione periodica, il monitoraggio dei bias, la trasparenza e il divieto di discriminazione algoritmica. ↑

302. Equità digitale: per non generare nuove disuguaglianze, sono previsti canali tradizionali paralleli per chi non dispone di strumenti digitali — segnatamente le persone anziane delle aree interne e montane — e il supporto multilingue per la popolazione straniera, particolarmente rilevante nell'area centrale, ferma restando la garanzia dell'alternativa in presenza. [↑](#)
303. Protezione dei dati: misure di sicurezza robuste — crittografia e pseudonimizzazione per le analisi — consenso modulare anche in forma digitale, collaborazione con l'Autorità garante e acquisizione di software dotati di marcatura adeguata secondo le normali procedure. [↑](#)
304. Benchmark statunitense (Collaborative Care): modello a équipe integrata, validato da oltre novanta studi controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri. [↑](#)
305. Esperienze italiane: le sperimentazioni locali, fra cui quelle riconducibili al modello di Solano nel Lazio, anticipano l'integrazione psicologica nelle cure primarie; ad esse si aggiunge oggi, come riferimento italiano fondato su una legge regionale dedicata, la sperimentazione toscana avviata in attuazione della legge 39 del 2022. I dati delle sperimentazioni storiche derivano però da campioni limitati e in parte da letteratura grigia, e vanno assunti con la dovuta cautela. [↑](#)
306. Trasferibilità: i risultati internazionali provengono da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale; la loro trasposizione richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche. [↑](#)
307. Evidenza locale toscana: la Toscana dispone di una base di evidenza locale peculiare, costituita dalla sperimentazione del servizio di psicologia di base avviata in attuazione della legge regionale 39 del 2022, attiva dal settembre 2024 e progressivamente estesa, che nei primi diciotto mesi ha preso in carico circa 2.300 cittadini con una valutazione positiva; è un'esperienza italiana fondata su una legge dedicata, che fornisce dati di esito reale da analizzare e valorizzare sistematicamente nel disegno del servizio strutturato. [↑](#)
308. Condizioni toscane favorevoli alla trasferibilità: il vantaggio peculiare della Toscana è di non dover trasferire soltanto stime estere, ma di poter validare il modello sui propri dati operativi; a ciò si aggiungono l'infrastruttura informatica regionale, la rete delle Case della Comunità e delle Case della Salute e la struttura amministrativa consolidata in sole tre Aziende USL, che costituiscono un terreno favorevole alla valutazione rigorosa di un modello già in esercizio. [↑](#)
309. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative: il rapporto di 4:1 spesso citato e l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio sono semplificazioni a fini divulgativi. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8:1-5,5:1. [↑](#)
310. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. La Toscana presenta un saldo di mobilità sanitaria nettamente attivo, dell'ordine di 58 milioni di euro, che la colloca tra le regioni più attrattive, trainata dalle grandi Aziende Ospedaliero-Universitarie: a differenza di una regione passiva, il canale del recupero della mobilità non costituisce qui una leva di risparmio, poiché la regione è già creditrice e l'attrazione riguarda la specialistica e il ricovero, non la domanda psicologica. Ne consegue che il saldo diretto risulta lievemente negativo e che il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi; in un contesto di pressione finanziaria e di liste di attesa, tuttavia, il contenimento della domanda impropria assume una salienza diretta. [↑](#)
311. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (6,2%) e non estratti dai conti regionali certificati delle tre Aziende USL e delle quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare prima della presentazione esterna;

in Toscana, tuttavia, essa è mitigata dalla disponibilità dei dati operativi reali prodotti dalla sperimentazione già in corso. ↑

312. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
313. Valutazione controfattuale d'impatto: poiché il servizio è già attivo in forma sperimentale, il disegno non può fondarsi su un dispiegamento scaglionato a partire da zero; esso sfrutta tre elementi. Il primo è il confronto prima-dopo l'attivazione del settembre 2024. Il secondo è l'estensione scaglionata tra le strutture e le zone — da Firenze Centro nell'autunno 2024, alle ulteriori dieci sedi dal marzo 2025, fino alle ventuno strutture del 2026 — che configura un disegno quasi a cunei progressivi, prezioso per l'inferenza. Il terzo è l'eterogeneità dell'intensità di copertura. L'effetto causale è stimato con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico; il vantaggio peculiare della Toscana è la disponibilità di dati italiani di esito reale. ↑
314. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione, tre Aziende USL, quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, Organismo Toscano di Governo Clinico, Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, Ordine degli Psicologi della Toscana, rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e università di Firenze, Pisa e Siena. A differenza del Veneto, la Toscana non dispone di un'azienda regionale unica, ma presenta la struttura più consolidata tra le regioni esaminate, con sole tre grandi Aziende USL accorpate dal 2016 e un ente regionale di supporto tecnico-amministrativo; il coordinamento avviene attraverso la Regione e tale assetto, unito a una legge già vigente, rende la sfida del governo quella di strutturare e dimensionare un servizio già avviato, non di introdurlo. ↑
315. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑
316. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. L'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per la loro adozione. ↑
317. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. ↑
318. ↑
319. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. Questa parte copre il settimo dominio del modello HTA, il profilo organizzativo, e fornisce il contenuto del caso commerciale e del caso gestionale del Five Case Model, rispondendo al criterio di sostenibilità. ↑
320. Modello RE-AIM: misura la riuscita e la validità esterna dell'attuazione lungo cinque dimensioni — la portata (quota della popolazione bersaglio raggiunta), l'efficacia (esiti conseguiti), l'adozione (adesione di sedi e professionisti), l'implementazione (fedeltà al modello) e il mantenimento (sostenibilità nel tempo); per la Toscana la dimensione del mantenimento è dirimente, trattandosi di consolidare a regime un servizio già avviato in via sperimentale. ↑

321. Quadro consolidato per la ricerca sull'implementazione (CFIR): spiega i determinanti dell'attuazione, articolati in cinque domini — le caratteristiche dell'innovazione, il contesto esterno, il contesto interno, gli individui coinvolti e il processo di attuazione — consentendo l'individuazione ex ante di barriere e facilitatori. ↑
322. Determinanti di implementazione seguiti dallo studio: il tasso di copertura, il grado di adozione delle sedi, la fedeltà al modello, i tempi di dimensionamento, il numero di psicologi reclutati e formati, la qualità della formazione e della supervisione, il grado di integrazione nei flussi di lavoro, l'aderenza ai percorsi e la scalabilità. ↑
323. Disegno del dimensionamento in Toscana: poiché il servizio è già attivo in via sperimentale in ventuno strutture delle tre Aziende USL, il dispiegamento non procede da zero, ma consiste nell'estensione progressiva della copertura — oggi dell'ordine del 5% del fabbisogno — a tutte le Case della Comunità verso il regime, per fasi semestrali e a partire dalle zone di maggiore prontezza, sotto il coordinamento unitario della Regione e secondo criteri trasparenti. ↑
324. Doppia funzione del dimensionamento progressivo: esso risponde a un'esigenza organizzativa — accrescere la copertura in modo graduale, compatibile con i tempi del reclutamento e della formazione — e al tempo stesso, insieme al confronto prima-dopo l'attivazione del settembre 2024 e alla progressione per cunei tra le strutture, fonda la valutazione controfattuale d'impatto basata sull'eterogeneità dell'intensità di copertura, oggetto della Parte L. ↑
325. Reclutamento: a fronte di un fabbisogno a regime dell'ordine di 790 psicologi, il reclutamento avviene tramite l'iscrizione a un elenco istituito presso ciascuna azienda e l'instaurazione di un rapporto convenzionale, con requisiti di iscrizione all'albo e di formazione specifica; in prima applicazione si valorizzano i professionisti già operanti nella sperimentazione, oggi con incarichi libero-professionali a venticinque ore, dei quali la strutturazione a regime stabilizzerebbe la posizione. ↑
326. Cronoprogramma: il dimensionamento procede per fasi semestrali, accrescendo progressivamente la copertura in tutte le Aziende USL; le attività di reclutamento, formazione e consolidamento sono condotte in modo graduale, mentre il monitoraggio e la valutazione accompagnano l'intero arco e proseguono oltre il raggiungimento del regime. ↑
327. Soglia di riuscita: tra i parametri che muterebbero le conclusioni figura un tasso di recupero inferiore al 50% nella fase di dimensionamento, a fronte del valore di riferimento del programma inglese; il monitoraggio è chiamato a verificarne il raggiungimento sui dati toscani, di cui la sperimentazione già attiva costituisce una prima fonte. ↑
328. Caso commerciale (Five Case Model): la fattibilità dell'assetto contrattuale poggia sul rapporto convenzionale ancorato all'accordo della specialistica ambulatoriale, da cui un costo medio per incarico dell'ordine di 55.000 euro l'anno e gli scenari di spesa di 22, 33 e 44 milioni già esposti nella Parte E; il passaggio dagli attuali incarichi libero-professionali della sperimentazione a un rapporto convenzionale stabile — analogo a quello dei medici di medicina generale — è il nodo specifico della Toscana e non richiede la creazione di nuove figure. ↑
329. Caso gestionale (Five Case Model): l'attuazione è governata su due livelli. A livello regionale, un comitato di indirizzo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo, riunendo la Regione, le tre Aziende USL, le quattro Aziende Ospedaliere-Universitarie, l'Organismo Toscano di Governo Clinico, l'ente regionale di supporto tecnico-amministrativo, l'Ordine degli Psicologi della Toscana, la medicina generale, la pediatria di libera scelta e le università di Firenze, Pisa e Siena; a livello aziendale, ciascuna Azienda USL è responsabile dell'attuazione nel proprio ambito, secondo l'indirizzo unitario della Regione. A differenza del Veneto, la Toscana non dispone di un'azienda regionale unica, ma la struttura consolidata in sole tre Aziende USL agevola il coordinamento. ↑

330. Rischi attuativi e misure di mitigazione: il rischio più specifico della Toscana è la precarietà della fase sperimentale, affidata a incarichi libero-professionali dipendenti da rifinanziamenti periodici; ad esso si aggiungono il reclutamento insufficiente, la debole adesione della medicina generale e l'interoperabilità incompleta dei sistemi informativi. Poiché la legge è già vigente, la principale misura di mitigazione è la strutturazione a regime con un rapporto convenzionale stabile, a superamento degli incarichi libero-professionali; il dimensionamento graduale consente inoltre di osservare, correggere e adattare. ↑
331. Caso finanziario e coperture (Five Case Model): le fonti di copertura comprendono il finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, dell'ordine di 8 miliardi di euro, di cui una quota è già destinata alla sperimentazione attiva, la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'infrastruttura territoriale e digitale, e un eventuale fondo statale a sostegno dei livelli essenziali. ↑
332. Vincoli di bilancio: la Toscana opera sotto pressione finanziaria, pur non essendo in piano di rientro ed essendo regione creditrice; il costo del servizio, anche a massima copertura, costituisce una frazione dell'ordine di mezzo punto percentuale del finanziamento, ed essendone già a bilancio una quota, l'investimento incrementale è quello necessario a colmare il divario verso il fabbisogno, sostenibile a condizione di prudenza nella programmazione. ↑
333. Sostenibilità nel tempo (criterio OCSE-DAC): per la Toscana la leva decisiva della sostenibilità non è l'istituzionalizzazione per legge, già acquisita, ma la strutturazione a regime con un rapporto convenzionale stabile, che sottrarrebbe il servizio alla precarietà dei rifinanziamenti periodici; vi concorrono la modestia del costo rispetto al bilancio, il forte ritorno sociale documentato e le economie di scala consentite dalla struttura consolidata in tre Aziende USL. ↑
334. Nota di cautela metodologica: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la verifica empirica sui dati toscani, prevista dalla Parte L e fondata sul confronto prima-dopo e sull'intensità di copertura, è chiamata a sostituire progressivamente le stime con misure osservate. ↑
335. Aspettativa di vita alla nascita dell'ordine degli ottantatré anni, in linea con la media nazionale; la struttura per età è tra le più anziane del Paese, con una quota di ultrasessantacinquenni intorno al ventisei per cento, e le proiezioni indicano una perdita dell'ordine del quattro per cento dei residenti al 2040 e del dodici per cento al 2060. ↑
336. Componente straniera dell'ordine dell'11,8% dei residenti (433.381 persone), superiore alla media nazionale, con prevalenza di cittadinanze romena, cinese e albanese; oltre la metà risiede nelle province di Firenze, Prato e Pisa, con una concentrazione particolarmente elevata a Prato, dove la componente cinese costituisce la maggioranza degli stranieri residenti. A differenza di altre regioni, la dimensione multiculturale è in Toscana un tratto rilevante del bisogno, che richiede competenza culturale nell'assistenza. ↑
337. Articolazione del territorio in dieci province: circa la metà dei residenti vive nelle province di Firenze, Pisa e Lucca, lungo l'asse urbano centrale che congiunge Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli; il restante è distribuito tra le altre province, con una quota significativa in aree interne e montane. ↑
338. Profilo per età a marcata variabilità interna: l'area metropolitana centrale, lungo l'asse Firenze-Prato-Pisa, presenta la struttura più dinamica, mentre le aree interne e montane — l'Amiata, la Garfagnana, la Lunigiana, l'Alta Valdicecina, il Casentino — sono nettamente più anziane e soggette a spopolamento, con maggiore difficoltà di accesso ai servizi, in parte mitigata dai flussi migratori in alcune di esse. ↑
339. ↑
340. Profilo per età a marcata variabilità interna: l'area metropolitana centrale, lungo l'asse Firenze-Prato-Pisa, presenta la struttura più dinamica, mentre le aree interne e montane — l'Amiata, la Garfagnana, la Lunigiana, l'Alta Valdicecina, il Casentino — sono nettamente più anziane e soggette a spopolamento, con

maggiore difficoltà di accesso ai servizi, in parte mitigata dai flussi migratori in alcune di esse. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Dipartimenti di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. ↑

341. ↑

342. Profilo per età a marcata variabilità interna: l'area metropolitana centrale, lungo l'asse Firenze-Prato-Pisa, presenta la struttura più dinamica, mentre le aree interne e montane — l'Amiata, la Garfagnana, la Lunigiana, l'Alta Valdicecina, il Casentino — sono nettamente più anziane e soggette a spopolamento, con maggiore difficoltà di accesso ai servizi, in parte mitigata dai flussi migratori in alcune di esse. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Dipartimenti di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Identificazione dei costi: il costo del servizio comprende le remunerazioni dei psicologi, i costi organizzativi e di coordinamento e la quota destinata alla formazione congiunta; è stimato per scenario di copertura ed espresso a regime. ↑

343. Costo del servizio per scenario, a regime: dell'ordine di 22 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 33 nello scenario base e 44 nello scenario espansivo, valori coerenti con l'inclusione del programma di formazione all'intelligenza artificiale. ↑

344. Metodo di stima del costo: il valore unitario per incarico è dell'ordine di 55.000 euro annui; la stima è regionalizzata in proporzione alla popolazione e al numero di professionisti, con economie di scala consentite dalla struttura consolidata in sole tre Aziende USL. La sperimentazione è oggi finanziata su base libero-professionale, ma per un importo che copre una frazione ridotta del fabbisogno. ↑

345. Identificazione e misura degli esiti: gli esiti di salute sono espressi in anni di vita ponderati per la qualità e in esiti clinici validati; i tassi di recupero e di miglioramento sono desunti dai benchmark consolidati e applicati in via prudenziale. ↑

346. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi (questionario a nove voci sui sintomi depressivi e scala a sette voci per il disturbo d'ansia); tasso di recupero di riferimento dell'ordine del 50%. ↑

347. Costo-efficacia e costo-utilità: il costo per anno di vita ponderato per la qualità si colloca al di sotto della soglia comunemente adottata; l'analisi per paziente, sviluppata nella Parte F, indica condizioni di dominanza dell'intervento rispetto all'opzione di non intervento. ↑

348. Soglia di costo-efficacia di riferimento dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, coerente con la prassi internazionale della valutazione economica in sanità. ↑

349. ↑

350. Soglia di costo-efficacia di riferimento dell'ordine di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, coerente con la prassi internazionale della valutazione economica in sanità. Questa parte organizza la misurazione dell'intervento nel tempo: serve ex post i criteri della griglia di giudizio, chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva della regolamentazione e fornisce il fondamento empirico delle stime delle parti precedenti. ↑

351. Modello di Donabedian per la qualità dell'assistenza: distingue le dimensioni di struttura, processo ed esito, qui integrate dalla dimensione dell'impatto, che coglie gli effetti più ampi sul sistema e sulla società. ↑

352. Batteria di indicatori: circa cinquantotto misure articolate in otto categorie, delle quali una parte è già ricavabile dalle statistiche correnti e dai dati della sperimentazione attiva, e circa quaranta richiedono la rilevazione diretta strutturata. ↑

353. Set di esiti essenziali: l'iniziativa COMET e gli standard ICHOM individuano, mediante consenso strutturato (metodo Delphi), un nucleo parsimonioso di esiti da misurare, evitando la proliferazione di misure ridondanti. ↑
354. Le otto categorie di indicatori e lo stato della baseline: bisogno e domanda (disponibile), accesso ed equità (da rilevare), processo (parziale, dalla sperimentazione), esito clinico (parziale, dalla sperimentazione), economici (misto), impatto sociale (misto), organizzativi (da rilevare), variabili di sintesi (da calcolare); i divari tra le tre Aziende USL sono tra le misure di equità. ↑
355. Protocollo minimo di rilevazione: attivo dal primo giorno, registra la presa in carico, ogni seduta, i punteggi di esito raccolti a ogni incontro, gli invii e le restituzioni, deliberatamente essenziale per non gravare sull'attività clinica; in Toscana si tratta di strutturare e completare la rilevazione già in atto nella sperimentazione. ↑
356. Strumenti di esito: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9), con punteggio totale da 0 a 27, soglia di rilevanza clinica intorno a 10 e cambiamento affidabile dell'ordine di 6 punti, e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7), impiegati nei soli punteggi complessivi. ↑
357. Modello di misurazione dei programmi inglesi di terapie psicologiche: la raccolta delle misure di esito a ogni seduta, e non solo all'inizio e alla fine, consente di calcolare il tasso di recupero e il miglioramento affidabile e di non protrarre percorsi inefficaci. ↑
358. Costituzione della baseline su due binari: gli indicatori già disponibili dalle statistiche correnti — demografici, epidemiologici, di benessere, di mortalità — forniscono la fotografia del prima, cui in Toscana si aggiunge il periodo anteriore all'attivazione del settembre 2024 quale base per il confronto prima-dopo; la rilevazione strutturata di servizio completa quella già avviata. ↑
359. Calendario della rilevazione: costituzione della baseline con i dati disponibili e con il periodo pre-attivazione; registrazione corrente; trasmissione di indicatori aggregati al comitato di indirizzo regionale con cadenza mensile; calcolo periodico delle misure di sintesi e aggiornamento del cruscotto regionale. ↑
360. Valutazione controfattuale d'impatto: misura l'effetto causale dell'intervento confrontando gli esiti dei trattati con il controfattuale, ciò che sarebbe accaduto in loro assenza, per definizione non osservabile direttamente; poiché il servizio è già attivo in via sperimentale, lo strumento non è un dispiegamento da zero, ma il confronto prima-dopo l'attivazione del settembre 2024 e, soprattutto, l'estensione scaglionata della sperimentazione tra le strutture e le zone — dal primo avvio nell'autunno 2024 fino alle ventuno strutture — che, unita all'eterogeneità dell'intensità di copertura, configura un disegno quasi a cunei progressivi idoneo a misurare gli effetti reali del servizio. ↑
361. Differenza-nelle-differenze: confronta la variazione nel tempo dell'esito tra le strutture e le zone attivate prima e quelle attivate dopo, e a maggiore e minore intensità di copertura, sotto l'ipotesi di andamento parallelo; vi si affianca il controllo sintetico, che costruisce un'unità di confronto artificiale come combinazione ponderata di zone non ancora attivate o a copertura inferiore. ↑
362. Effetti stimati e validità: l'analisi restituisce l'effetto medio sull'intera popolazione e l'effetto medio sui soli trattati; i disegni a cunei progressivi e a esperimento naturale sono, per gli interventi di salute della popolazione, lo strumento raccomandato dalla letteratura metodologica; la validità esterna va valutata a parte. ↑
363. Trasformazione delle stime in prove: confrontando l'andamento, ad esempio, degli accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche nelle zone attivate per prime e a copertura più intensa con quello delle zone attivate più tardi, si isola l'effetto proprio della riforma e si trasforma la stima dei risparmi da proiezione attesa a misura empiricamente fondata sui dati toscani. ↑

364. Verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (VIR; DPCM 169/2017): è valutazione ex post, di norma dopo un biennio, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attuazione della norma, che chiude il ciclo aperto dall'analisi preventiva. ↑
365. Clausola valutativa: sul piano regionale, impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti; in Toscana, dove il servizio è già istituito dalla legge regionale 39 del 2022, tale clausola si innesta su una base legislativa già esistente e lega la misurazione tecnica alla responsabilità politica e alla trasparenza verso il legislatore regionale. ↑
366. Manuale OCSE-JRC per la costruzione di indicatori compositi (2008): articola in dieci passi la costruzione e la validazione delle misure di sintesi, dalla selezione delle variabili alla normalizzazione, alla ponderazione e all'analisi di robustezza. ↑
367. Benessere Equo e Sostenibile (BES), ISTAT: dodici domini con indici compositi; con la legge n. 163/2016 di riforma del bilancio, una selezione di indicatori è entrata nel ciclo della programmazione economica, a precedente istituzionale dell'impiego di misure di sintesi nella decisione pubblica. ↑
368. Regole di coerenza e di non duplicazione: il divieto di doppia contabilizzazione impone che, nel medesimo calcolo, una grandezza sia conteggiata una sola volta, segnatamente nella separazione tra risparmi diretti e ricadute sociali già adottata nella Parte E. ↑
369. Risparmi diretti complessivi per il Servizio sanitario regionale stimati nell'ordine di 14 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 22 nello scenario base e 34 nello scenario espansivo, collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa dell'intervallo e al netto del canale della mobilità, qui nullo. ↑
370. Saldo diretto per il bilancio sanitario, dato dalla differenza tra risparmi diretti e costo del servizio, dell'ordine di -8, -11 e -10 milioni di euro annui nei tre scenari: è lievemente negativo, coerentemente con la condizione di regione creditrice, per la quale il canale della mobilità non concorre al pareggio diretto. ↑
371. Il saldo diretto negativo è dichiarato senza attenuazioni e non costituisce una debolezza dell'analisi, ma il suo profilo onesto: a differenza della Puglia, dove il recupero della mobilità passiva concorre al pareggio diretto, in Toscana la regione è già creditrice e il valore dell'intervento risiede in misura preponderante nelle ricadute economico-sociali; tuttavia, in un contesto di pressione finanziaria e di liste di attesa, il contenimento della domanda impropria conserva una salienza diretta non trascurabile. ↑
372. Ritorno sociale: le ricadute economico-sociali comprendono il valore della maggiore produttività recuperata, la riduzione delle nuove invalidità e dei pensionamenti anticipati, le efficienze nel sistema dei servizi di salute mentale e il sollievo alle figure di cura familiari. In una delle regioni più anziane d'Italia, a forte presenza di cronicità, le componenti della produttività recuperata e del sollievo ai familiari hanno un peso particolarmente elevato. ↑
373. Ricadute economico-sociali stimate nell'ordine di 71 milioni di euro annui nello scenario conservativo, 133 nello scenario base e 207 nello scenario espansivo, secondo i metodi del ritorno sociale sull'investimento, con criteri di stima conservativi. ↑
374. Ritorno complessivo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali, dell'ordine di 85, 155 e 241 milioni di euro annui nei tre scenari; il saldo complessivo, al netto del costo del servizio, è dell'ordine di +63, +122 e +197 milioni di euro annui. ↑
375. Rapporto beneficio-costo complessivo dell'ordine di 3,9:1 nello scenario conservativo, 4,7:1 nello scenario base e 5,5:1 nello scenario espansivo, in linea con il valore validato sulle altre regioni e coerente con le stime metodologicamente fondate della letteratura. ↑
376. Caso economico e caso finanziario secondo il Five Case Model: il caso finanziario, riferito al solo bilancio sanitario, presenta un saldo diretto lievemente negativo; il caso economico, riferito alla collettività, è ampiamente positivo. La distinzione tra le due grandezze è la chiave dell'analisi. ↑

377. Sostenibilità finanziaria: il costo del servizio si colloca nell'ordine dello 0,3-0,5% di un Fondo Sanitario Regionale dell'ordine di 8 miliardi di euro; benché la regione operi sotto pressione finanziaria, l'importo è contenuto e sostenibile, tanto più che una quota è già a bilancio per la sperimentazione attiva, e l'investimento incrementale è quello necessario a colmare il divario verso il fabbisogno. ↑
378. Lacuna prioritaria: le grandezze economiche qui impiegate sono in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione (6,2%) e non estratte dai conti regionali certificati delle tre Aziende USL e delle quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie; la loro verifica è condizione per la presentazione alle autorità di finanza pubblica, ed è in Toscana agevolata dai dati operativi della sperimentazione. ↑
379. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 730.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato dall'offerta strutturata attuale; la sperimentazione già attiva ne ha intercettato una quota ancora ridotta, con circa 2.300 prese in carico nei primi diciotto mesi. ↑
380. Modello organizzativo: lo psicologo di base opera nelle Case della Comunità e nelle Case della Salute, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, secondo gli indirizzi operativi dell'Organismo Toscano di Governo Clinico; nel modello toscano il servizio è già attivo in via sperimentale nelle tre Aziende USL. A differenza del Veneto, la Toscana non dispone di un'azienda regionale unica, ma presenta la struttura più consolidata tra le regioni esaminate — tre grandi Aziende USL e un ente regionale di supporto tecnico-amministrativo — sicché il coordinamento, l'omogeneità attuativa e le economie di scala sono assicurati dalla Regione, attraverso la sua Direzione competente e l'organismo di governo clinico. ↑
381. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
382. Percorso clinico: accesso su invio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nella forma già in atto nella sperimentazione regionale, o accesso diretto; valutazione iniziale; ciclo di colloqui brevi; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. ↑
383. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
384. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
385. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
386. ↑
387. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). Questa parte conclusiva applica la griglia di giudizio del telaio, i criteri dell'OCSE-DAC, che attraversano l'intero studio come metro di valutazione e convergono qui nella sintesi; fornisce inoltre il contenuto del caso strategico del Five Case Model. ↑
388. Criteri di valutazione dell'OCSE-DAC (rivisti nel 2019, «Better Criteria for Better Evaluation»): sei lenti complementari — rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità — che insieme danno un quadro complessivo dell'intervento. ↑

389. Rilevanza: l'intervento risponde a un bisogno reale e di grande dimensione — dell'ordine di 730.000 persone con disagio comune in larga parte inevaso — e all'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza. ↑
390. Coerenza: l'intervento è compatibile e complementare con gli standard dell'assistenza territoriale (DM 77/2022), con la Missione 6 del PNRR e con la legge regionale che già ne ha istituito la funzione — la legge 39 del 2022 e il suo regolamento di attuazione — ed è costituzionalmente difendibile; la Toscana, pur sotto pressione finanziaria, non è sottoposta a piano di rientro ed è regione creditrice nella mobilità. ↑
391. Efficacia: l'evidenza internazionale documenta che i modelli di integrazione della salute mentale nelle cure primarie raggiungono gli obiettivi clinici, con tassi di recupero dell'ordine del 50% nel programma inglese; i dati della sperimentazione toscana già attiva ne corroborano la praticabilità. ↑
392. Efficienza: l'intervento è favorevole in termini di costo-utilità — con dominanza per paziente e costo-efficacia confermata dall'analisi probabilistica — a fronte, per la Toscana, di un saldo diretto lievemente negativo sul solo bilancio sanitario, di entità modesta rispetto a un finanziamento dell'ordine di 8 miliardi; l'efficienza allocativa è dunque elevata, la convenienza per il solo bilancio lievemente negativa. ↑
393. Impatto: l'impatto distributivo è favorevole, poiché i benefici si concentrano dove l'accesso è più difficile — le aree interne e montane, l'età anziana, l'utenza straniera e le popolazioni gravate dalle liste di attesa — riducendo il gradiente territoriale; il ritorno complessivo è dell'ordine di 3,8-5,5 a uno. ↑
394. Sostenibilità: l'intervento è finanziariamente sostenibile — a fronte di un costo modesto, di una pluralità di coperture e di una quota già a bilancio per la sperimentazione attiva — e organizzativamente, in quanto già inserito nella rete territoriale delle Case della Comunità e delle Case della Salute; poiché la legge è già vigente, la leva decisiva della sua durata non è l'istituzionalizzazione per legge, ma la strutturazione a regime con un rapporto convenzionale stabile, che sottrarrebbe il servizio alla precarietà dei rifinanziamenti periodici. ↑
395. Analisi multi-criterio (buone pratiche ISPOR): rende esplicito il bilanciamento dei criteri non riducibili a denaro — l'equità, la fattibilità, la coerenza strategica, la robustezza dell'evidenza — attribuendo a ciascuno un peso e a ciascuna opzione un punteggio. ↑
396. Risultato dell'analisi multi-criterio: su otto criteri pesati, l'opzione di intervento ottiene un punteggio complessivo dell'ordine di 82,65 su 100 contro 39,25 dell'opzione zero, e prevale su tutti i criteri tranne la fattibilità immediata; i sub-punteggi di fattibilità e di robustezza dell'evidenza sono peraltro più elevati che negli altri contesti esaminati, poiché la Toscana dispone già sia di una legge regionale dedicata sia di una sperimentazione attiva con dati di esito propri, e il risultato è stabile rispetto ai pesi adottati. ↑
397. Le tre affermazioni del cruscotto decisionale per la Toscana: il servizio costa al bilancio sanitario una cifra modesta e comporta un saldo diretto lievemente negativo, trascurabile rispetto a un finanziamento dell'ordine di 8 miliardi, pur con una salienza diretta non nulla nel contesto delle liste di attesa; il ritorno per la collettività è ampio (rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno); il valore poggia quasi interamente sulle ricadute sociali. ↑
398. Raccomandazione centrale: la decisione rilevante non è se introdurre la funzione — già istituita dalla legge regionale 39 del 2022 e attiva in via sperimentale — né se dotarla di una legge, già esistente, ma se portarla dalla sperimentazione alla strutturazione a regime, convertendo gli incarichi libero-professionali in un rapporto convenzionale analogo a quello dei medici di medicina generale, e dimensionarla, portandola dalla copertura attuale, dell'ordine del 5% del fabbisogno, alla copertura sistematica, dell'ordine di 600 incarichi nello scenario di base. ↑
399. Cruscotto secondo il Quintuple Aim: la sintesi del valore è letta lungo le cinque dimensioni dell'esito di salute, dell'esperienza, del costo, del benessere degli operatori e dell'equità. ↑

400. Limite principale (radicamento nei dati): le grandezze economiche sono in parte ricostruite a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione toscana (6,2%), e non estratte dai conti regionali certificati delle tre Aziende USL e delle quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie; tale sostituzione è la condizione per la presentazione agli organi di controllo, ed è in Toscana agevolata dalla disponibilità dei dati della sperimentazione già attiva. ↑
401. Cautele di trasferibilità e di fonte: i risultati italiani disponibili provengono in parte da letteratura grigia e da campioni limitati, e i benchmark esteri richiedono adattamento al contesto; la cifra del ritorno è prudenziale e non ponderata per l'equità. ↑
402. Agenda di ricerca: l'investimento conoscitivo prioritario è l'acquisizione dei dati regionali certificati presso le tre Aziende USL e le quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, seguito dalla strutturazione della rilevazione di servizio e dalla valutazione controfattuale fondata sul confronto prima-dopo l'attivazione del settembre 2024 e sull'estensione scaglionata tra le strutture. ↑
403. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale; la sperimentazione già attiva ha prodotto dati di attività — circa 2.300 cittadini in carico in diciotto mesi, con dati di invio e di filtro — che costituiscono una base preziosa, da consolidare in un flusso strutturato. ↑
404. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑
405. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
406. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
407. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: in Toscana sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle aree interne e montane, più anziane e soggette a spopolamento, come l'Amiata, la Garfagnana e la Lunigiana; la sperimentazione ha già mostrato adesione anche nei piccoli centri e nelle zone montane, e tali strumenti sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza. ↑
408. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
409. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso le Università di Firenze, Pisa e Siena); post-universitario specialistico (corso regionale con attestato sulla psicologia di base e le cure primarie, comprensivo della competenza per l'età anziana, per le aree interne e della competenza culturale per l'utenza straniera); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). ↑
410. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. L'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. ↑
411. ↑
412. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. L'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata

dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. Questa parte sviluppa i metodi di modellazione e di gestione dell'incertezza del quinto dominio, secondo le buone pratiche di ricerca sulla modellazione dell'ISPOR e dell'Accademia delle scienze, ed è riportata secondo lo standard CHEERS 2022. ↑

413. Modello di Markov a coorte, strumento standard della valutazione economica in sanità: rappresenta il decorso del disturbo mentale comune come successione di transizioni tra stati di salute mutuamente esclusivi (sintomatico, recupero, cronico, morte), scanditi da cicli con correzione di metà ciclo; la microsimulazione ne costituisce la variante per le traiettorie individuali. ↑
414. Risultati del caso base (singolo paziente, orizzonte di cinque anni, valori scontati): il braccio dell'intervento produce un costo sanitario di circa 2.495 euro e un'utilità di 3,627 anni di vita ponderati, contro un costo di circa 3.799 euro e un'utilità di 3,392 dell'assistenza usuale; l'intervento è quindi meno costoso (di circa 1.304 euro) e più efficace (di circa 0,236 anni), configurando una dominanza. ↑
415. La dominanza si spiega con la struttura del modello: a fronte di un costo iniziale contenuto, l'intervento accresce il tempo trascorso nello stato di recupero, a bassa utilizzazione di risorse, e riduce il tempo trascorso nello stato cronico, ad alta utilizzazione, sicché il risparmio a valle eccede il costo a monte. Il risultato per paziente è il fondamento microeconomico delle stime aggregate della Parte E ed è indipendente dalla regione. ↑
416. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. ↑
417. ↑
418. Parametri di costo del modello (per ciclo): stato di recupero 40 euro, stato cronico 700 euro, intervento psicologico una tantum 300 euro; è la struttura di costo a generare la dominanza, poiché lo stato cronico, che l'intervento riduce, è di gran lunga il più oneroso. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudenziale per l'ottimismo delle stime. ↑
419. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
420. Quadro economico consolidato per la Toscana (Parte E): a regime, da circa 400 a circa 790 psicologi, costo del servizio di 22-44 milioni, risparmi diretti di 14-34 milioni, ricadute sociali di 71-207 milioni; il saldo diretto è lievemente negativo, il saldo complessivo positivo, con rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno. ↑
421. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
422. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio. ↑
423. Valori regionali di ancoraggio per la Toscana: popolazione di 3.657.716 abitanti (Censimento ISTAT 2024) in lieve calo e con marcato invecchiamento, tra le più anziane d'Italia, finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 8 miliardi di euro sotto pressione finanziaria ma senza piano di rientro in atto, saldo di mobilità nettamente attivo (regione creditrice), fabbisogno a regime fino a circa 790 psicologi nello scenario espansivo. ↑

424. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione toscana (6,2%), e non estratti dai conti regionali certificati; i dati da acquisire presso le tre Aziende USL e le quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie sono elencati nella tabella seguente, agevolati in Toscana dalla disponibilità dei dati della sperimentazione già attiva. ↑
425. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑
426. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni agli studi pugliese, lombardo, veneto, emiliano-romagnolo e piemontese, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑
427. Analisi di sensibilità a una via: ciascun parametro è fatto variare del 25% in più e in meno, misurandone l'effetto sul beneficio monetario netto; il diagramma a tornado ordina i parametri per influenza, con l'efficacia clinica, i tassi di ricaduta e di cronicizzazione e il costo dello stato cronico tra i più influenti. ↑
428. Incertezza strutturale: oltre all'incertezza dei parametri, l'incertezza sulla struttura e sulle assunzioni del modello è trattata mediante analisi di scenario, e i risultati sono riportati secondo lo standard CHEERS, con validazione della coerenza interna ed esterna. ↑
429. Analisi di sensibilità probabilistica: il modello è eseguito diecimila volte con estrazione casuale dei parametri dalle rispettive distribuzioni (simulazione Monte Carlo), propagando l'incertezza dei parametri sull'incertezza del risultato. ↑
430. Soglia di disponibilità a pagare di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, valore di riferimento nella prassi italiana e internazionale. ↑
431. Curva di accettabilità della costo-efficacia: alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è dell'88,9% e la probabilità che sia dominante dell'84,6%; il beneficio monetario netto medio sulle diecimila iterazioni è di circa 7.815 euro per paziente, con intervallo di credibilità al 95% da circa -5.736 a circa +21.501 euro. ↑
432. Distinzione tra costo-utilità e impatto sul bilancio per la Toscana: la probabilità di costo-efficacia è un risultato di efficienza, riferito al singolo paziente, che valorizza il guadagno di salute e l'intera traiettoria di costo del modello; esso è coerente con il saldo diretto aggregato della Parte E, che per la Toscana è lievemente negativo, poiché la traduzione dal modello per paziente all'aggregato regionale incorpora le correzioni per peso morto e per l'effettiva monetizzabilità nel bilancio dei costi evitati, e poiché il canale della mobilità è inapplicabile, essendo la Toscana nettamente creditrice. L'efficienza per paziente è robusta; la convenienza per il solo bilancio è lievemente negativa; il forte ritorno per la collettività proviene dalle ricadute sociali. ↑
433. Valore dell'informazione: il valore atteso dell'informazione perfetta quantifica il beneficio massimo conseguibile eliminando del tutto l'incertezza, e il valore atteso dell'informazione perfetta sui parametri indica quali parametri sia prioritario misurare con precisione. ↑
434. ↑
435. Posizione del Lazio: la Regione non dispone, allo stato, di una legge regionale dedicata, ma si colloca in una fase pre-legislativa nella quale sono depositate una proposta di legge di iniziativa consiliare (PdL 138, recante l'istituzione del servizio di assistenza psicologica primaria) e una proposta di legge di iniziativa popolare di analogo oggetto, con una dotazione stimata dell'ordine di 14 milioni di euro l'anno e un obiettivo di uno psicologo ogni quindicimila abitanti, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale. Il Lazio è al tempo stesso la culla accademica del modello, elaborato a Roma nell'ambito della psicologia delle cure primarie, e ha già conosciuto una prima esperienza nei Punti Unici di Accesso nella scorsa legislatura. ↑

436. Valore dell'informazione e priorità di ricerca: l'analisi del valore atteso dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione laziale, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle dieci Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliero-universitarie e la raccolta dei dati di esito a partire dall'istituzione del servizio. ↑
437. Mitigazione progressiva della lacuna: il disegno prospettico consente di colmare la lacuna dei dati mano a mano che il servizio entra a regime, generando un'evidenza locale propria che corregge progressivamente le stime importate dai benchmark; il Lazio passa così, in modo programmato, da una valutazione fondata su dati esterni a una fondata su dati propri. ↑
438. Sintesi della modellazione: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione dei dati, e la posizione pre-legislativa della regione — lungi dal costituire soltanto un ritardo — si rivela, sul piano della valutazione, un vantaggio, perché consente di disegnare la prova empirica nel modo metodologicamente più solido. ↑
439. Disagio giovanile: è una componente rilevante e in crescita, con fenomeni di ansia, depressione e disturbi del comportamento alimentare tra gli adolescenti che solo in parte trovano risposta nei servizi. ↑
440. Salute mentale connessa al lavoro: nella vasta popolazione attiva dell'area metropolitana, ampia parte dei lavoratori è esposta a fattori di stress correlati al lavoro; l'intercettazione precoce del disagio ha un valore particolarmente elevato in termini di produttività recuperata. ↑
441. Bisogno dell'età anziana: la domanda connessa all'invecchiamento, alla cronicità e alla comorbidità psicologica delle patologie croniche è particolarmente accentuata nelle province interne di Rieti e Viterbo, più anziane e a maggiore difficoltà di accesso. ↑
442. Tratto distintivo del Lazio rispetto alle altre regioni: la combinazione di una grande regione policentrica e fortemente accentrata su Roma, della condizione di culla scientifica del modello e, al tempo stesso, di una posizione pre-legislativa, in cui il servizio non è ancora istituito per legge. Il bisogno è quindi accompagnato da una solida legittimazione scientifica ma da un ritardo normativo, che la decisione è chiamata a colmare istituendo il servizio. ↑
443. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche significativi: rapportando alla popolazione laziale il dato nazionale, dell'ordine di alcune decine di migliaia l'anno, indice di una pressione sul sistema acuto che un primo livello territoriale efficace potrebbe in parte contenere a monte. ↑
444. Offerta territoriale: il Lazio non dispone, allo stato, di un servizio di psicologia territoriale strutturato; sono depositate una proposta di legge di iniziativa consiliare e una di iniziativa popolare, con una dotazione stimata dell'ordine di 14 milioni di euro l'anno e un obiettivo di uno psicologo ogni quindicimila abitanti, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, prioritariamente nelle Case della Comunità. La pregressa esperienza nei Punti Unici di Accesso costituisce un precedente, ma non un servizio a regime. ↑
445. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 1.230 psicologi nello scenario espansivo (e dell'ordine di 620 e 930 negli scenari conservativo e di base). L'Ordine degli Psicologi del Lazio, che ha accompagnato l'iniziativa legislativa, ne sostiene l'approvazione e la strutturazione a regime. ↑
446. Copertura attuale del fabbisogno pressoché nulla a regime: in assenza di un servizio strutturato e di una legge, e a fronte della sola pregressa esperienza nei Punti Unici di Accesso, la distanza dalla copertura adeguata è la più ampia dell'intera serie regionale, e la decisione verte sull'istituire il servizio e colmarla. ↑
447. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante nel Lazio si gioca su due assi. Il primo è interno all'area metropolitana romana, fra il centro e una periferia ampia con sacche di deprivazione e di difficile accesso. Il secondo separa l'area metropolitana dalle province interne, anziane, disperse e in spopolamento.

La telepsicologia assistita è lo strumento per avvicinare l'offerta alle aree interne e alle periferie, dove la sola presenza di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio. ↑

448. Finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 12-13 miliardi di euro; il Lazio è in uscita da un piano di rientro durato dal 2007, con i conti riportati in attivo (utile nel 2023, avanzo nel 2024) e l'autonomia fiscale recuperata, e ha dunque appena riacquisito margini di programmazione, pur con fragilità residue nei tempi di pagamento di alcune Aziende; è attivo un Piano di programmazione dell'assistenza territoriale 2024-2026 e il ricorso al privato accreditato è ampio. ↑
449. Mobilità sanitaria a profilo bidirezionale: il Lazio è al tempo stesso forte attrattore — unica regione del Centro-Sud, trainata dalle grandi strutture romane — e fonte di una rilevante mobilità passiva, con un saldo netto negativo ma in miglioramento. Poiché la fuga si concentra nelle prestazioni ospedaliere e chirurgiche di alta complessità, e non nella domanda psicologica delle cure primarie, il canale del recupero della mobilità è solo marginalmente pertinente a questo intervento. ↑
450. Cornice normativa e programmatica: il Lazio non dispone di una legge regionale dedicata, ma di proposte in itinere — di iniziativa consiliare e popolare. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale e il Piano regionale di azioni per la salute mentale 2022-2024; sul piano nazionale, il testo unificato C. 1140, il Piano Nazionale per la Salute Mentale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 sulla competenza regionale. A differenza di Toscana e Liguria, il Lazio è ancora in fase pre-legislativa. ↑
451. Popolazione residente nel Lazio 5.709.178 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 9,7% della popolazione nazionale — la regione più popolosa tra quelle finora esaminate — in lieve calo rispetto all'anno precedente per effetto di un saldo naturale fortemente negativo, solo in parte compensato dal saldo migratorio estero. La distribuzione è fortemente concentrata: la Città Metropolitana di Roma Capitale raccoglie circa il 74% dei residenti, mentre le restanti province — Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti — e le aree interne presentano un invecchiamento più marcato e dinamiche di spopolamento. La componente straniera, intorno all'11,4%, è superiore alla media nazionale. ↑
452. ↑
453. Popolazione residente nel Lazio 5.709.178 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 9,7% della popolazione nazionale — la regione più popolosa tra quelle finora esaminate — in lieve calo rispetto all'anno precedente per effetto di un saldo naturale fortemente negativo, solo in parte compensato dal saldo migratorio estero. La distribuzione è fortemente concentrata: la Città Metropolitana di Roma Capitale raccoglie circa il 74% dei residenti, mentre le restanti province — Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti — e le aree interne presentano un invecchiamento più marcato e dinamiche di spopolamento. La componente straniera, intorno all'11,4%, è superiore alla media nazionale. Equità come dominio della valutazione: l'analisi distributiva non è un'appendice, ma un dominio proprio dell'HTA, poiché un intervento può essere efficiente nel complesso e tuttavia accrescere le disuguaglianze, o al contrario ridurle; lo studio impiega l'analisi di costo-efficacia distributiva per misurarne l'effetto sui divari, oltre che sull'efficienza. ↑
454. Gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori. ↑
455. Barriere all'accesso: il ricorso al sostegno psicologico è ostacolato da barriere economiche, geografiche e culturali, oltre che dallo stigma; nel Lazio la componente straniera, intorno all'11,4% e concentrata nell'area romana, aggiunge una barriera linguistica e culturale che richiede competenza dedicata. ↑

456. Doppio asse della disuguaglianza nel Lazio: a differenza di regioni dal divario prevalentemente unidimensionale, il Lazio presenta due assi distinti. Il primo è interno alla vasta area metropolitana romana, fra il centro e una periferia ampia con sacche di deprivazione e difficoltà di accesso. Il secondo separa l'area metropolitana dalle province interne — Rieti e Viterbo in particolare — anziane, disperse e in spopolamento. La struttura distributiva del bisogno è perciò più complessa che altrove. ↑
457. Primo asse, la periferia metropolitana: nell'area romana, accanto a quartieri centrali ben serviti, si estendono periferie popolate con sacche di deprivazione socio-economica, dove la difficoltà di accesso ai servizi e la minore disponibilità di offerta privata accrescono il bisogno non intercettato. ↑
458. Secondo asse, le province interne: Rieti e Viterbo, e le aree montane e collinari interne, presentano una popolazione più anziana, dispersa e in spopolamento, dove la rarefazione dei servizi e le distanze rendono l'accesso al sostegno psicologico particolarmente difficoltoso. ↑
459. Effetto del servizio sull'equità: la gratuità, la prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano le principali barriere all'accesso, e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso; è il meccanismo attraverso cui un servizio universale riduce, anziché accrescere, il divario. ↑
460. Telepsicologia assistita: nel Lazio è lo strumento per avvicinare l'offerta alle province interne e alle periferie metropolitane, dove le distanze e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; concepita come complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, essa estende la copertura proprio nelle aree a maggiore difficoltà di accesso. ↑
461. Competenza culturale: l'efficacia dell'intervento presso la popolazione straniera richiede mediazione linguistica e competenza culturale, affinché la barriera linguistica non si traduca in un minore accesso; è una condizione di equità particolarmente rilevante nell'area metropolitana romana. ↑
462. Costo-efficacia distributiva: l'analisi indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, in quanto i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto; l'intervento è quindi favorevole all'equità, oltre che costo-efficace. ↑
463. Modulazione territoriale della copertura: per realizzare il potenziale di equità, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle periferie metropolitane e alle province interne; un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un'allocazione ponderata per il bisogno li riduce. ↑
464. Mobilità e equità: nel Lazio il canale della mobilità non costituisce una leva di equità per questo intervento, poiché la fuga riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica e non la domanda psicologica territoriale; l'equità si gioca quindi interamente sull'accesso interno, fra centro e periferie e fra area metropolitana e aree interne. ↑
465. Rischio di iniquità inversa: se l'istituzione del servizio privilegiasse, per facilità organizzativa, le aree già meglio servite del centro metropolitano, l'effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell'allocazione delle sedi e degli incarichi, fin dalla fase di istituzione. ↑
466. Sintesi dell'equità: l'intervento è favorevole all'equità su entrambi gli assi del divario laziale, a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno e che siano garantite la telepsicologia per le aree interne e la competenza culturale per l'utenza straniera; la raccomandazione è di adottare, fin dall'istituzione, un'allocazione pro-equità che dia di più dove il bisogno è maggiore. ↑
467. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure;

assenza del servizio strutturato come comparatore. ↑

468. ↑

469. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; assenza del servizio strutturato come comparatore. Metodo della revisione: la sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche (PRISMA 2020) e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE; sono considerati studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. ↑

470. Studio fondativo del modello collaborativo (IMPACT), pubblicato su JAMA nel 2002: circa il 50% dei pazienti trattati ha conseguito una riduzione di almeno il 50% dei sintomi a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. ↑

471. Meta-analisi su cinquantasette studi controllati (2012): l'integrazione della cura ha prodotto un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard rispetto alla cura usuale. ↑

472. Revisione di quarantadue implementazioni del modello (2024): riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 43% dell'ansia a sei mesi, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. ↑

473. Programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies), dati reali 2023-2024: tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile del 67,8% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su una scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno. ↑

474. Meta-analisi sulle cure integrate: coefficiente standardizzato dell'ordine di -0,11 sui sintomi depressivi, di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante quando applicato a una popolazione ampia. ↑

475. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. ↑

476. Cautela metodologica rilevante: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi (l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero); il valore economico del modello poggia in misura preponderante sui ritorni sociali, non sui risparmi sanitari diretti. Questa cautela è coerente con il profilo del caso economico laziale, fondato anch'esso sulle ricadute sociali. ↑

477. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. ↑

478. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. ↑

479. ↑

480. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. Tre profili intrecciati: la fattibilità dell'intervento dipende dal presidio congiunto di un profilo giuridico (la competenza e la forma dell'atto), di un profilo organizzativo (l'assetto e la governance dell'istituzione) e di un profilo etico (le tutele a garanzia dei pazienti); lo studio li tratta unitariamente, poiché una debolezza in uno solo di essi comprometterebbe l'intera operazione. ↑

481. Profilo giuridico e riparto di competenza: la materia si colloca nella competenza legislativa concorrente in tema di tutela della salute; la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 ha delimitato lo spazio della disciplina regionale, che deve esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Il Lazio dispone quindi del titolo per istituire il servizio con legge propria, purché coordinata con la cornice nazionale. ↑
482. Stato pre-legislativo del Lazio: a differenza di Toscana e Liguria, dotate di una legge dedicata, il Lazio non dispone di una legge regionale istitutiva; sono depositate una proposta di legge di iniziativa consiliare e una di iniziativa popolare di analogo oggetto. La decisione giuridica rilevante è quindi l'approvazione della legge istitutiva, che costituisce il presupposto formale dell'intero intervento e che la regione deve compiere ex novo. ↑
483. Inquadramento del rapporto di lavoro: il modello prevalente, anche nelle proposte di legge in itinere, è quello del rapporto convenzionale su base libero-professionale, per analogia con la medicina generale e la pediatria di libera scelta, e non quello della dipendenza; tale forma assicura flessibilità e prossimità, e va presidiata sul piano delle tutele e della continuità del rapporto. ↑
484. Livelli essenziali di assistenza: la psicologia di base nelle cure primarie non è ancora esplicitamente ricompresa nei livelli essenziali di assistenza nazionali; la Regione può nondimeno istituirla con risorse proprie, nell'ambito della propria autonomia, e l'eventuale futuro riconoscimento nei livelli essenziali rafforzerebbe la stabilità del finanziamento. Nel frattempo, il servizio si fonda sulla copertura regionale. ↑
485. Cornice degli standard territoriali: il Decreto Ministeriale 77 del 2022 definisce gli standard dell'assistenza territoriale e individua nelle Case della Comunità il fulcro dell'integrazione delle cure primarie; il servizio di psicologia di base vi si inserisce coerentemente, come uno dei livelli di risposta al bisogno della popolazione. ↑
486. Rapporto con i servizi specialistici: il servizio di psicologia di base precede e alleggerisce i Centri di Salute Mentale, intercettando e trattando i quadri lievi e moderati e indirizzando a essi i casi che richiedono cure specialistiche; l'integrazione, e non la sovrapposizione, è il principio che ne governa il rapporto con la rete esistente. ↑
487. Assetto organizzativo: l'istituzione del servizio nel Lazio deve misurarsi con un sistema esteso e policentrico — dieci Aziende Sanitarie Locali, sei metropolitane e quattro provinciali, numerose aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS — e con l'assenza di un'azienda regionale unica, sicché il coordinamento è in capo alla Regione; garantire l'omogeneità attuativa fra le Aziende è la sfida organizzativa centrale. ↑
488. Governance dell'istituzione: l'avvio del servizio richiede una regia regionale che coordini le dieci Aziende Sanitarie Locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS, l'Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei; in assenza di un'azienda unica, la Regione esercita direttamente tale regia, definendo indirizzi operativi uniformi e un sistema di monitoraggio comune. ↑
489. Ruolo dell'Ordine professionale: l'Ordine degli Psicologi del Lazio, che ha accompagnato l'iniziativa legislativa, concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione e alla vigilanza deontologica; la sua collaborazione è condizione della qualità e dell'appropriatezza del servizio. ↑
490. Profilo etico, tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici; è una cautela che presidia l'intervento presso le fasce più fragili. ↑

491. Consenso e riservatezza: l'intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un'informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell'efficacia stessa del sostegno psicologico. ↑
492. Strumenti di intelligenza artificiale e quadro europeo: gli strumenti digitali eventualmente impiegati sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
493. Protezione dei dati personali: il trattamento è conforme alla normativa vigente, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑
494. Responsabilità professionale: il professionista resta pienamente responsabile delle decisioni cliniche, e gli strumenti di supporto, anche quelli basati sull'intelligenza artificiale, forniscono un ausilio non vincolante; la chiarezza sull'imputazione della responsabilità è condizione di un impiego sicuro e appropriato della tecnologia. ↑
495. Sintesi dei profili: i tre profili — giuridico, organizzativo ed etico — sono presidiable, e la condizione abilitante dell'intero intervento è l'approvazione della legge istitutiva, che il Lazio, a differenza delle regioni già dotate di una propria disciplina, deve ancora compiere; è questo l'atto da cui dipende il passaggio dalla proposta all'istituzione del servizio. ↑
496. Benchmark statunitense (Collaborative Care): modello a équipe integrata, validato da oltre novanta studi controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri. ↑
497. Esperienze italiane: il modello dell'integrazione psicologica nelle cure primarie ha una radice italiana proprio nel Lazio, dove è stato elaborato a Roma il modello dello psicologo nelle cure primarie, e dove la scorsa legislatura ha conosciuto una prima esperienza nei Punti Unici di Accesso; a ciò si aggiungono i servizi avviati nelle regioni dotate di una legge dedicata. I dati delle sperimentazioni storiche derivano però da campioni limitati e in parte da letteratura grigia, e vanno assunti con la dovuta cautela. ↑
498. Trasferibilità: i risultati internazionali provengono da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale; la loro trasposizione richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche. ↑
499. Evidenza locale laziale: a differenza della Toscana, dove una sperimentazione già matura fornisce dati di esito reale, il Lazio non dispone di un servizio attivo a regime e non ha quindi dati di esito propri attuali, se non per la pregressa esperienza nei Punti Unici di Accesso; l'evidenza locale è perciò, allo stato, prospettica. Lo studio poggia, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, sulla radice scientifica del modello nella regione e sul disegno valutativo, e dovrà essere corroborato dai dati prodotti una volta istituito il servizio. ↑
500. Condizioni laziali per la trasferibilità e la valutazione: pur non disponendo di dati operativi attuali, il Lazio presenta un terreno favorevole alla valutazione rigorosa, costituito dalla tradizione scientifica del modello, dall'infrastruttura informatica regionale e dalla rete delle Case della Comunità in costruzione; il vantaggio peculiare della regione è di poter disegnare la valutazione fin dall'istituzione del servizio, anziché ricostruirla a posteriori, così da generare un'evidenza locale solida e non soltanto importata. ↑
501. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative: il rapporto di 4:1 spesso citato e l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio sono semplificazioni a fini divulgativi; lo stesso vale per il rapporto di 2,5:1 talvolta richiamato in ambito regionale. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costo complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8:1-5,5:1. ↑

502. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. Il Lazio presenta un profilo di mobilità sanitaria peculiare: è al tempo stesso forte attrattore, trainato dalle grandi strutture romane, e fonte di una rilevante mobilità passiva, con un saldo netto negativo ma in miglioramento. Poiché la fuga si concentra nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica, e non nella domanda psicologica delle cure primarie, il canale del recupero della mobilità — leva centrale per le regioni debitrice del Mezzogiorno come la Puglia — è qui solo marginalmente pertinente a questo intervento. A ciò si aggiunge una circostanza finanziaria dirimente: il Lazio è in uscita da un piano di rientro durato dal 2007, con i conti riportati in attivo e l'autonomia fiscale recuperata, sicché la regione ha appena riguadagnato flessibilità di programmazione. Ne consegue che il saldo diretto risulta lievemente negativo e che il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi; in un contesto di liste di attesa, il contenimento della domanda impropria assume comunque una salienza diretta. ↑
503. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (9,7%) e non estratti dai conti regionali certificati delle dieci Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliero-universitarie: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare prima della presentazione esterna. A differenza della Toscana, inoltre, il Lazio non dispone ancora di un servizio strutturato a regime che produca dati di esito propri — se non per la pregressa esperienza nei Punti Unici di Accesso — sicché lo studio poggia, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, sull'eredità scientifica del modello elaborato nella regione e su un disegno valutativo prospettico. ↑
504. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
505. Valutazione controfattuale d'impatto: poiché il servizio non è ancora attivo a regime, il disegno può essere progettato fin dall'inizio come un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le dieci Aziende Sanitarie Locali e i loro distretti sono stabiliti in anticipo a fini valutativi. È la condizione metodologicamente più favorevole dell'intera serie, poiché il Lazio muove dalla legislazione e non da una sperimentazione già in corso da ricostruire a posteriori; l'effetto causale è stimato con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico. ↑
506. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione, dieci Aziende Sanitarie Locali, aziende ospedaliero-universitarie (Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, San Camillo-Forlanini, San Giovanni-Addolorata, Sant'Andrea), grandi IRCCS e policlinici, Ordine degli Psicologi del Lazio, rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e atenei romani (Sapienza in primis, Tor Vergata, Roma Tre, Cattolica, Campus Bio-Medico). A differenza del Veneto, il Lazio non dispone di un'azienda regionale unica, e a differenza della Toscana presenta una struttura ampia e articolata — dieci Aziende Sanitarie Locali, sei nell'area metropolitana romana e quattro provinciali, oltre a numerose aziende ospedaliere e IRCCS — con coordinamento in capo alla Regione; la sfida del governo è quindi quella di istituire e dimensionare il servizio ex novo, garantendo l'omogeneità attuativa in un sistema esteso e policentrico. ↑
507. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑
508. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. L'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per la loro adozione. ↑

509. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. ↑
510. ↑
511. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. I cinque casi della decisione di investimento pubblico: lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile; la convergenza dei cinque casi è condizione della solidità della decisione. ↑
512. Caso strategico: l'istituzione del servizio è coerente con la cornice nazionale degli standard territoriali, con la centralità delle Case della Comunità e con il Piano regionale di azioni per la salute mentale; nel Lazio essa presenta una coerenza ulteriore, poiché dà forma istituzionale a un modello elaborato proprio nella regione, sanando la distanza fra la sua paternità scientifica e la sua mancata istituzione normativa. ↑
513. Caso economico: rinvia ai risultati della valutazione economica — un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,9-5,5 a uno e una dominanza per paziente con elevata probabilità — nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di modesto disavanzo e un caso sociale fortemente positivo. ↑
514. Caso commerciale: il modello del rapporto convenzionale su base libero-professionale è praticabile e si avvale, nel Lazio, di un bacino professionale ampio, alimentato dai numerosi atenei romani; la disponibilità di psicologi qualificati non costituisce un vincolo all'avvio, a differenza di quanto potrebbe accadere in contesti a minore densità formativa. ↑
515. Caso finanziario: il costo del servizio a regime — dell'ordine di 34, 51 e 68 milioni di euro nei tre scenari, pari allo 0,3-0,5% del finanziamento sanitario regionale — è sostenibile, tanto più che il Lazio è in uscita da un lungo piano di rientro, con i conti riportati in attivo e l'autonomia fiscale recuperata; la dotazione delle proposte di legge, dell'ordine di 14 milioni l'anno, finanzia la prima fase di avvio. ↑
516. Caso gestionale: la realizzabilità dipende da una regia regionale che, in assenza di un'azienda unica, coordini le dieci Aziende Sanitarie Locali, le aziende ospedaliere-universitarie e gli IRCCS, l'Ordine professionale, la medicina generale e la pediatria di libera scelta e gli atenei, con indirizzi operativi uniformi e un sistema di monitoraggio comune. ↑
517. Dimensionamento ex novo: a differenza delle regioni che strutturano un servizio già avviato, il Lazio deve dimensionare il servizio a partire da zero, verso un fabbisogno a regime dell'ordine di 1.230 psicologi nello scenario espansivo; la prima fase, corrispondente alla dotazione delle proposte di legge, si colloca nell'ordine di 255 incarichi, e l'estensione procede per gradi verso gli scenari di base ed espansivo. ↑
518. Fasi di attuazione: l'attuazione si articola in una fase di avvio, nella quale il servizio è attivato in un primo insieme di Case della Comunità secondo un disegno scaglionato tra le Aziende; una fase di estensione, nella quale la copertura si amplia progressivamente; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato al fabbisogno. Il disegno scaglionato dell'avvio coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F. ↑
519. Reclutamento e formazione: l'avvio richiede il reclutamento e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino professionale ampio dell'area romana e la radice accademica del modello costituiscono una base favorevole, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze. ↑

520. Cronoprogramma: l'attuazione si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; l'avvio è però subordinato all'approvazione della legge istitutiva, che costituisce il presupposto temporale di tutte le fasi successive e che colloca il Lazio in una posizione di partenza più arretrata rispetto alle regioni già dotate di una disciplina. ↑
521. Sostenibilità finanziaria: la leva della sostenibilità, nel Lazio, è l'approvazione della legge, l'istituzione del servizio e il suo dimensionamento progressivo; i margini di programmazione riacquistati con l'uscita dal piano di rientro rendono praticabile l'investimento, mentre l'eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe in futuro la stabilità. ↑
522. Sostenibilità organizzativa: la sfida è garantire l'omogeneità attuativa fra le dieci Aziende Sanitarie Locali in un sistema esteso e policentrico privo di un'azienda regionale unica; la sostenibilità organizzativa dipende dalla forza della regia regionale e dalla chiarezza degli indirizzi operativi. ↑
523. Monitoraggio dell'attuazione: l'avanzamento è seguito mediante indicatori di processo — sedi attivate, incarichi conferiti, prese in carico — raccolti attraverso un flusso informativo che, poiché il servizio nasce ora, può essere progettato fin dall'inizio in modo completo e uniforme. ↑
524. Rischi principali dell'attuazione: la disomogeneità attuativa fra le Aziende in un sistema policentrico; la difficoltà di coordinamento in assenza di un'azienda unica; e la dipendenza dell'intero avvio dall'iter legislativo, che introduce un'incertezza temporale propria della posizione pre-legislativa. ↑
525. Mitigazioni: i rischi sono fronteggiati con una regia regionale forte e indirizzi operativi uniformi, con il disegno scaglionato dell'avvio che consente un apprendimento progressivo, e con un'allocazione pro-equità che orienta l'estensione verso le aree a maggiore bisogno; la chiarezza del cronoprogramma e il sostegno dell'Ordine professionale concorrono a ridurre l'incertezza. ↑
526. Sintesi dell'attuazione: l'intervento è attuabile e sostenibile, e la leva propria del Lazio è l'approvazione della legge e l'avvio dimensionato del servizio; la regione parte da zero, ma dispone di un bacino professionale ampio, di una tradizione scientifica favorevole e dei margini riacquistati con l'uscita dal piano di rientro, sicché le condizioni di fattibilità sono complessivamente favorevoli. ↑
527. Struttura per età in moderato invecchiamento: l'età media è dell'ordine di 46,7 anni ed è in crescita, su valori inferiori a quelli delle regioni più anziane del Centro-Nord; le proiezioni indicano un indice di vecchiaia in forte aumento entro il 2050. L'invecchiamento è disomogeneo: più contenuto nell'area metropolitana e nelle province di Latina e Roma, più marcato nelle province interne di Rieti e Viterbo e nei piccoli comuni in spopolamento. ↑
528. Componente straniera dell'ordine dell'11,4% dei residenti (651.033 persone), superiore alla media nazionale, con concentrazione nell'area romana; è il flusso migratorio estero a sostenere la popolazione e a frenare l'invecchiamento, a fronte di un saldo naturale strutturalmente negativo. ↑
529. Distribuzione territoriale fortemente concentrata: la Città Metropolitana di Roma Capitale raccoglie circa il 74% dei residenti (oltre quattro milioni, di cui circa 2,75 milioni nel solo comune di Roma); seguono a grande distanza le province di Latina (~9,9%), Frosinone (~8,1%), Viterbo (~5,4%) e Rieti (~2,6%). ↑
530. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato la vasta area metropolitana romana, densamente popolata e con una periferia ampia che presenta sacche di deprivazione; dall'altro le province interne, anziane e in spopolamento, dove la rarefazione dei servizi e le distanze acuiscono le difficoltà di accesso. ↑
531. ↑
532. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato la vasta area metropolitana romana, densamente popolata e con una periferia ampia che presenta sacche di deprivazione; dall'altro le province interne, anziane e in spopolamento, dove la rarefazione dei servizi e le distanze acuiscono le difficoltà di accesso. Definizione: lo

psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. ↑

533. ↑

534. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato la vasta area metropolitana romana, densamente popolata e con una periferia ampia che presenta sacche di deprivazione; dall'altro le province interne, anziane e in spopolamento, dove la rarefazione dei servizi e le distanze acuiscono le difficoltà di accesso. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Impianto della valutazione economica: lo studio impiega congiuntamente l'analisi costo-utilità, che rapporta il costo agli anni di vita ponderati per la qualità; l'analisi di impatto sul bilancio, che misura la sostenibilità finanziaria esercizio per esercizio; e l'analisi del ritorno sociale, che valuta il valore generato per la collettività. La doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società distingue rigorosamente i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali più ampie. ↑

535. Costo del servizio: assumendo un costo medio annuo per incarico dell'ordine di 55.000 euro, comprensivo degli oneri, i tre scenari di copertura corrispondono a un costo annuo a regime dell'ordine di 34 milioni di euro nello scenario conservativo (circa 620 psicologi), 51 milioni nello scenario di base (circa 930) e 68 milioni nello scenario espansivo (circa 1.230), nel modello del rapporto convenzionale a impegno orario definito. ↑

536. Scenari di copertura del fabbisogno: lo scenario conservativo, di base ed espansivo rappresentano gradi crescenti di copertura della popolazione con disagio comune, verso la copertura piena del fabbisogno. La dotazione indicata dalle proposte di legge in itinere, dell'ordine di 14 milioni di euro l'anno, corrisponde a circa 255 incarichi e costituisce un punto d'ingresso iniziale, inferiore allo stesso scenario conservativo; gli scenari qui considerati rappresentano il regime e non la prima fase di avvio. ↑

537. Risparmio diretto sugli accessi impropri al pronto soccorso: dell'ordine di 4, 6 e 8 milioni di euro l'anno nei tre scenari, per effetto della riduzione degli accessi per cause psichiatriche e somatoformi intercettabili a livello territoriale. ↑

538. Risparmio diretto sulla spesa farmaceutica: dell'ordine di 4, 7 e 11 milioni di euro l'anno, per effetto della riduzione delle prescrizioni inappropriate di antidepressivi e ansiolitici nei quadri lievi, in favore dell'intervento psicologico. ↑

539. Risparmio diretto su ricoveri e specialistica: dell'ordine di 12, 19 e 32 milioni di euro l'anno, per effetto della riduzione di ricoveri evitabili, consulti specialistici ripetuti e accertamenti inappropriate connessi a disagio non riconosciuto. ↑

540. Recupero della mobilità sanitaria: per il Lazio il contributo è marginale, dell'ordine di 2 milioni di euro l'anno in tutti gli scenari, valore puramente simbolico. Il profilo di mobilità della regione è bidirezionale — forte attrazione e rilevante fuga, con saldo netto passivo ma in miglioramento — ma la fuga si concentra nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica, non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché questo canale, leva centrale per le regioni debitorie del Mezzogiorno, non costituisce qui una fonte di risparmio significativa per questo intervento. ↑

541. ↑

542. Recupero della mobilità sanitaria: per il Lazio il contributo è marginale, dell'ordine di 2 milioni di euro l'anno in tutti gli scenari, valore puramente simbolico. Il profilo di mobilità della regione è bidirezionale — forte attrazione e rilevante fuga, con saldo netto passivo ma in miglioramento — ma la fuga si concentra

nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica, non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché questo canale, leva centrale per le regioni debitorie del Mezzogiorno, non costituisce qui una fonte di risparmio significativa per questo intervento. Finalità del monitoraggio e della valutazione ex post: rendere conto dell'impiego delle risorse, apprendere dall'esperienza e correggere il corso dell'attuazione; la valutazione non è un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l'istituzione del servizio si traduce in apprendimento istituzionale, ed è ancorata a una clausola valutativa. ↑

543. Impianto secondo i tre livelli di struttura, processo ed esito: la valutazione distingue le condizioni e le risorse del servizio (struttura), le attività e il loro svolgimento (processo) e i risultati conseguiti (esito), in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti. ↑
544. Disegno controfattuale prospettico: poiché nel Lazio il servizio non è ancora attivo, la valutazione d'impatto può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le dieci Aziende Sanitarie Locali e i loro distretti sono stabiliti in anticipo a fini valutativi; è il disegno metodologicamente più solido dell'intera serie regionale, reso possibile dal fatto che la regione muove dalla legislazione e non da una sperimentazione già in corso da ricostruire a posteriori. ↑
545. Misurazione di base anteriore all'istituzione: il vantaggio di partire da zero consente di rilevare una linea di base completa prima dell'avvio del servizio, contro la quale misurare l'effetto; è una condizione che le regioni con un servizio già attivo non possono più ricostruire pienamente, e che rende la stima dell'effetto laziale particolarmente affidabile. ↑
546. Metodi di stima dell'effetto: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze, che confronta l'evoluzione delle aree già attivate con quella delle aree non ancora attivate, e con il metodo del controllo sintetico, che costruisce un termine di confronto a partire dai dati osservati; la progressione scaglionata fornisce la variazione necessaria all'identificazione. ↑
547. Indicatori di struttura: numero di sedi attivate nelle Case della Comunità, incarichi conferiti, ore di servizio disponibili, dotazione tecnologica e copertura territoriale rispetto al fabbisogno; misurano la capacità effettivamente installata. ↑
548. Indicatori di processo: prese in carico, tempo di attesa al primo colloquio, numero di colloqui per persona, tasso di invio appropriato ai servizi specialistici e aderenza ai percorsi clinici; misurano il funzionamento del servizio. ↑
549. Indicatori di esito clinico: quota di miglioramento e tasso di recupero, misurati con gli strumenti validati nei soli punteggi complessivi, e remissione dei quadri trattati; misurano il beneficio diretto per le persone. ↑
550. Indicatori di esito di sistema: accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche, prescrizioni di psicofarmaci nei quadri lievi, ricoveri evitabili e consultazioni specialistici impropri; misurano l'effetto dell'intervento sul resto del sistema. ↑
551. Indicatori economici: costo del servizio, risparmi diretti per canale, ricadute economico-sociali e rapporto beneficio-costi, calcolati su dati reali man mano disponibili; consentono di verificare ex post le stime dello studio e di sostituire progressivamente i valori ricostruiti con quelli effettivi. ↑
552. Indicatori di equità: copertura e accesso disaggregati per area — centro e periferie metropolitane, province interne — e per gruppi di popolazione, compresa l'utenza straniera; verificano che il servizio riduca i divari anziché accrescerli, coerentemente con l'allocazione pro-equità raccomandata. ↑
553. Indicatori di qualità: soddisfazione degli utenti, appropriatezza delle prese in carico e degli invii, continuità del rapporto e qualità percepita della relazione; integrano la misurazione degli esiti con la dimensione dell'esperienza. ↑

554. Indicatori di mobilità: per il Lazio sono monitorati ma non costituiscono un esito atteso dell'intervento, poiché la fuga riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica e non la domanda psicologica territoriale; la loro rilevazione serve a confermare l'irrelevanza del canale per questo intervento, non a documentarne un effetto. ↑
555. Batteria complessiva di indicatori: l'insieme è organizzato in otto categorie — struttura, processo, esito clinico, esito di sistema, economici, equità, qualità e mobilità — per un totale dell'ordine di cinquantotto indicatori, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile della rilevazione; la batteria è comune alla serie e adattata al contesto laziale. ↑
556. Cruscotto regionale di monitoraggio: gli indicatori confluiscono in un cruscotto aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; in assenza di un'azienda regionale unica, la titolarità del cruscotto è in capo alla Regione, che ne assicura l'alimentazione uniforme da parte delle dieci Aziende. ↑
557. Clausola valutativa: lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa, da prevedere espressamente nella futura legge istitutiva, che impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio sull'attuazione e sui risultati del servizio; nel Lazio essa va inserita fin dal testo di legge, cogliendo l'occasione che la posizione pre-legislativa offre. ↑
558. Flusso informativo: la raccolta dei dati di processo e di esito poggia su un flusso informativo che, poiché il servizio nasce ora, può essere progettato fin dall'inizio in modo completo, uniforme e interoperabile con il fascicolo sanitario elettronico regionale, senza dover recuperare a posteriori dati frammentari. ↑
559. Tempi della valutazione: la valutazione si articola in un momento ex ante, con la rilevazione della linea di base prima dell'avvio; in un monitoraggio in itinere, che accompagna l'estensione; e in una valutazione ex post, che misura l'effetto a regime e ne verifica la sostenibilità; è una sequenza che il disegno prospettico laziale consente di realizzare integralmente. ↑
560. Sintesi del monitoraggio: la valutazione è la condizione per trasformare l'istituzione del servizio in apprendimento, e il Lazio può disegnarla nella forma più completa, dalla linea di base alla valutazione ex post; perché ciò si realizzi, la clausola valutativa e il flusso informativo vanno previsti fin dal testo di legge, facendo della posizione pre-legislativa un'occasione anziché un ritardo. ↑
561. Ricadute economico-sociali per la collettività: dell'ordine di 110, 207 e 320 milioni di euro l'anno nei tre scenari, comprensive del recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo, del valore del benessere recuperato e del minor carico assistenziale sulle famiglie; sono stimate con criteri conservativi. ↑
562. Ritorno complessivo annuo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali: dell'ordine di 132, 241 e 373 milioni di euro nei tre scenari. Detratto il costo del servizio, il saldo complessivo per la collettività è ampiamente positivo, dell'ordine di +98, +190 e +305 milioni di euro l'anno. ↑
563. Rapporto beneficio-costi complessivo: dell'ordine di 3,9 a uno nello scenario conservativo, 4,7 a uno in quello di base e 5,5 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale di 3,8-5,5 a uno adottata dallo studio e coerente con le stime metodologicamente fondate della letteratura. ↑
564. Distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico: è il punto che lo studio tiene fermo per il Lazio e che ne governa la lettura. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, poiché i risparmi diretti non coprono per intero il costo del servizio e il canale della mobilità è marginale. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il solo ritorno complessivo

come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe. La decisione va assunta riconoscendo che si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto per il bilancio sanitario. ↑

565. Tabella economica consolidata: riepiloga, per i tre scenari, il costo del servizio, i risparmi diretti per canale, il saldo diretto, le ricadute sociali, il ritorno complessivo, il saldo complessivo e il rapporto beneficio-costi; è lo strumento sintetico per la decisione e distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale. ↑
566. Analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni, sconto del 3%): il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 euro del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: meno costoso e più efficace. Il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. ↑
567. Analisi di sensibilità probabilistica (diecimila simulazioni): l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, e dominante nell'84,6%; il beneficio monetario netto medio per paziente è dell'ordine di 7.815 euro, con un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. La robustezza del risultato clinico-economico per paziente è elevata, distintamente dall'incertezza sulle grandezze aggregate di sistema. ↑
568. Impatto sul bilancio e sostenibilità: il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta del finanziamento sanitario regionale, dell'ordine dello 0,3% nello scenario conservativo e dello 0,5% in quello espansivo. La sostenibilità è favorita dalla circostanza che il Lazio è in uscita da un lungo piano di rientro, con i conti riportati in attivo e l'autonomia fiscale recuperata: la regione dispone oggi di margini di programmazione che fino a pochi anni or sono non aveva, e che rendono praticabile un investimento di questa entità. ↑
569. Lacuna dei dati e sua mitigazione: le grandezze economiche sono allo stato in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione (9,7%) e non estratte dai conti certificati delle dieci Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliero-universitarie; inoltre, a differenza della Toscana, il Lazio non dispone ancora di un servizio attivo che produca dati di esito propri. La stima poggia perciò sui benchmark internazionali, sulla radice scientifica del modello nella regione e sul disegno valutativo prospettico; è la lacuna prioritaria da colmare prima della presentazione esterna, mediante l'estrazione dei dati certificati e la raccolta dei dati di esito a partire dall'istituzione del servizio. ↑
570. Sintesi della valutazione economica: il caso diretto è prudente e di modesto disavanzo per il bilancio sanitario; il caso sociale è robusto e fortemente positivo; il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità. La coerenza con la cautela metodologica già enunciata — i risparmi sanitari diretti non sono certi sul piano statistico — è piena: il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali, non in un risparmio di bilancio che lo studio si astiene dal rivendicare. ↑
571. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 1.150.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato dall'offerta strutturata attuale; poiché il servizio non è ancora istituito, l'intervento va dimensionato fin dal principio sul fabbisogno, e non a partire da una sperimentazione già in corso. ↑
572. Modello organizzativo: lo psicologo di base opera nelle Case della Comunità, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impianto delle proposte di legge in itinere, che prevedono uno psicologo ogni quindicimila abitanti e l'inserimento nei distretti territoriali. Nel modello laziale il servizio va istituito ex novo nelle dieci Aziende Sanitarie Locali; a differenza del Veneto, la Regione non dispone di un'azienda regionale unica, e il coordinamento è in capo alla Regione, sicché l'omogeneità attuativa in un sistema esteso e policentrico — sei Aziende metropolitane e quattro provinciali — è la sfida organizzativa principale. ↑

573. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
574. Percorso clinico: accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista; valutazione iniziale e progetto clinico individuale; ciclo di colloqui brevi e programma di sostegno personalizzato; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. Il percorso poggia su un modello clinico elaborato proprio nella regione, nell'ambito della psicologia delle cure primarie. ↑
575. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
576. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
577. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
578. ↑
579. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). Funzione della sintesi: la parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo, impiegando l'analisi multi-criterio per integrare in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie; non somma grandezze disomogenee, ma le pondera secondo criteri espliciti, rendendo verificabile il passaggio dall'evidenza alla raccomandazione. ↑
580. Sintesi per dominio: il bisogno è ampio e radicato in una regione che del modello è la culla scientifica; l'efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida e, per il Lazio, integrata da un disegno valutativo prospettico; il quadro economico distingue un caso finanziario di modesto disavanzo da un caso sociale fortemente positivo; l'equità è favorevole su un doppio asse territoriale; la fattibilità è quella di un'istituzione ex novo; il monitoraggio può essere disegnato nella forma più completa della serie. La convergenza dei domini sostiene una raccomandazione favorevole. ↑
581. Metodo dell'analisi multi-criterio: i criteri di valutazione sono otto, ciascuno con un peso esplicito — efficacia clinica, costo-efficacia e ritorno economico, impatto sul bilancio e sostenibilità, equità, valore sociale, fattibilità, robustezza dell'evidenza e coerenza strategica — e l'intervento è confrontato con l'alternativa del non intervento attribuendo a ciascuno un punteggio, la cui media ponderata fornisce il giudizio complessivo. ↑
582. Criteri e pesi adottati: efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno economico 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell'evidenza 10%, coerenza strategica 5%; la struttura dei pesi è comune a tutti gli studi della serie, a garanzia di confrontabilità. ↑
583. Punteggio dell'intervento: la media ponderata dei punteggi attribuiti all'intervento è dell'ordine di 78 su 100, sostenuta dai punteggi elevati nel valore sociale, nell'equità e nel ritorno economico, e contenuta dai punteggi più bassi nella robustezza dell'evidenza propria e nella fattibilità, che riflettono la posizione pre-legislativa della regione. ↑

584. Punteggio del non intervento: l'alternativa di non istituire il servizio ottiene una media ponderata dell'ordine di 39 su 100; essa è penalizzata in tutti i criteri sostanziali — efficacia, equità, valore sociale, ritorno — e è sostenuta soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, che però nel Lazio appare oggi meno giustificata, vista la disponibilità di margini finanziari riacquistati. ↑
585. Interpretazione del confronto: l'intervento prevale nettamente sul non intervento, con uno scarto dell'ordine di trentotto punti; il punteggio dell'intervento è il più contenuto fra quelli delle regioni esaminate di recente, e ciò non segnala una minore validità del modello, ma la posizione più precoce del Lazio, che deve ancora legiferare e non dispone di dati propri — elementi destinati a rafforzarsi con l'istituzione del servizio. ↑
586. Robustezza della raccomandazione: la prevalenza dell'intervento si mantiene anche facendo variare i pesi dei criteri entro intervalli ragionevoli; nessuna combinazione plausibile dei pesi rovescia il giudizio, sicché la raccomandazione è robusta rispetto alle scelte valoriali sottostanti alla ponderazione. ↑
587. Raccomandazione principale: si raccomanda di approvare la legge istitutiva del servizio di psicologia di base e di istituire il servizio ex novo, dotandolo dal principio di una forma stabile e di un dimensionamento adeguato; è la decisione che il Lazio, culla scientifica del modello, è chiamato a compiere per colmare la distanza fra la paternità dell'idea e la sua istituzione. ↑
588. Dimensionamento raccomandato: si raccomanda di muovere dall'avvio corrispondente alla dotazione delle proposte di legge, dell'ordine di 255 incarichi, e di procedere per gradi verso lo scenario di base, dell'ordine di 930 psicologi, e quindi verso lo scenario espansivo, dell'ordine di 1.230, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità. ↑
589. Condizioni della raccomandazione: l'inserimento della clausola valutativa nel testo di legge, l'adozione di un'allocatione pro-equità verso le periferie metropolitane e le province interne, una regia regionale forte in assenza di un'azienda unica e un flusso informativo progettato fin dall'inizio sono le condizioni che trasformano la raccomandazione in un'attuazione efficace e valutabile. ↑
590. Lacuna da colmare prima della presentazione esterna: l'estrazione dei conti certificati delle dieci Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliero-universitarie e la raccolta dei dati di esito a partire dall'istituzione del servizio sono le priorità che consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive e di generare un'evidenza locale propria. ↑
591. Distinzione cardine ribadita: la decisione va assunta riconoscendo che il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, mentre il caso economico complessivo, comprensivo delle ricadute sociali, è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto per il bilancio, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto. ↑
592. Collocazione nella serie regionale: lo studio sul Lazio è l'ottavo della serie, dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Liguria, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, il Lazio occupa la posizione più precoce, quella di una regione che del modello è la culla scientifica ma che deve ancora istituirlo per legge, e che proprio per questo può disegnarne fin dall'origine la valutazione nella forma più rigorosa. ↑
593. Avvertenza conclusiva sulle semplificazioni: lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico — il rapporto di quattro a uno, il moltiplicatore per dieci, il rapporto di due e mezzo a uno — e adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, coerente con le stime metodologicamente fondate; è una scelta di credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica. ↑

594. Conclusione: la decisione che lo studio sostiene è di approvare la legge istitutiva e di istituire il servizio di psicologia di base, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno e dotandolo di una clausola valutativa; per il Lazio, culla scientifica del modello, ciò significa chiudere il cerchio fra la paternità dell'idea e la sua istituzione, trasformando un primato scientifico in un servizio strutturato a beneficio della popolazione. ↑
595. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale. Poiché il servizio non è ancora attivo, il Lazio può progettare il flusso informativo fin dal primo giorno, in modo completo e uniforme, senza dover recuperare a posteriori dati frammentari: è la condizione più favorevole della serie. ↑
596. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑
597. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
598. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
599. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: nel Lazio sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nella vasta periferia metropolitana romana e nelle province interne, anziane e in spopolamento, dove le distanze e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; tali strumenti sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza. ↑
600. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
601. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso gli atenei romani, primo fra tutti la Sapienza, nel cui ambito il modello è stato elaborato, e inoltre Tor Vergata, Roma Tre, Cattolica e Campus Bio-Medico); post-universitario specialistico (formazione dedicata alla psicologia di base e alle cure primarie, comprensiva della competenza per l'età anziana, per le aree interne e della competenza culturale per l'utenza straniera); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). La radice accademica del modello nella regione costituisce una base formativa peculiare. ↑
602. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. L'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. ↑
603. ↑
604. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. L'infrastruttura informatica regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. Ruolo della modellazione: poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l'orizzonte direttamente osservabile, lo studio proietta costi ed esiti nel tempo mediante un modello decisionale, e ne governa l'incertezza con tecniche deterministiche e probabilistiche; la modellazione non genera certezze, ma rende esplicite e verificabili le assunzioni. ↑
605. Struttura del modello di Markov: la storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%; il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. ↑

606. Parametri principali del modello: a ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita; il costo per ciclo è dell'ordine di 40 euro per lo stato di recupero e di 700 euro per la cronicità, con l'intervento che comporta un costo una tantum dell'ordine di 300 euro; le grandezze sono trattate come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l'incertezza. ↑
607. Esito del caso base: l'intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell'ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità rispetto al comparatore; il risultato è robusto rispetto alle variazioni dei singoli parametri entro intervalli plausibili. ↑
608. Analisi di sensibilità deterministica a un parametro per volta: la variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — entro intervalli plausibili non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. ↑
609. ↑
610. Analisi di sensibilità deterministica a un parametro per volta: la variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — entro intervalli plausibili non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudentiale per l'ottimismo delle stime. ↑
611. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
612. Quadro economico consolidato per il Lazio (Parte E): a regime, da circa 620 a circa 1.230 psicologi, costo del servizio di 34-68 milioni, risparmi diretti di 22-53 milioni, ricadute sociali di 110-320 milioni; il saldo diretto è lievemente negativo, il saldo complessivo fortemente positivo, con rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno. ↑
613. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
614. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio; nel Lazio, poiché il servizio non è ancora attivo, possono essere definiti fin dall'istituzione, in forma completa e uniforme. ↑
615. Valori regionali di ancoraggio per il Lazio: popolazione di 5.709.178 abitanti (Censimento ISTAT 2024), la più popolosa della serie, in lievissimo calo per saldo naturale negativo compensato dal saldo migratorio, fortemente concentrata sull'area metropolitana di Roma (circa il 74%); finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 12-13 miliardi di euro, in uscita da un lungo piano di rientro con i conti riportati in attivo e l'autonomia fiscale recuperata; saldo di mobilità passivo ma con profilo bidirezionale, e fuga concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica; fabbisogno a regime fino a circa 1.230 psicologi nello scenario espansivo. ↑
616. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione laziale (9,7%), e non estratti dai conti regionali certificati; i dati da acquisire presso le dieci Aziende Sanitarie Locali e le aziende ospedaliere-universitarie sono elencati nella tabella seguente, e nel Lazio, a differenza della Toscana, la loro mancanza non è ancora mitigata da dati operativi, poiché il servizio non è stato ancora istituito. ↑
617. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑

618. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni agli studi pugliese, lombardo, veneto, emiliano-romagnolo, piemontese, toscano e ligure, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑
619. Analisi di sensibilità probabilistica su diecimila simulazioni: l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. ↑
620. Curva di accettabilità: alla soglia convenzionale di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è prossima al 90%, e cresce ulteriormente per soglie superiori; già a soglie molto inferiori l'intervento mantiene un'elevata probabilità di convenienza. ↑
621. Analisi di scenario: i tre scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; la dotazione delle proposte di legge in itinere, dell'ordine di 14 milioni di euro l'anno, corrisponde a un punto d'ingresso iniziale inferiore allo scenario conservativo, e costituisce la prima tappa di un percorso di estensione progressiva. ↑
622. Incertezza sulle grandezze aggregate: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce esplicitamente e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema. ↑
623. Disegno della verifica empirica: poiché nel Lazio il servizio non è ancora attivo, la verifica controfattuale può essere progettata fin dall'inizio come un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le dieci Aziende Sanitarie Locali e i loro distretti sono stabiliti in anticipo a fini valutativi. È la condizione metodologicamente più favorevole dell'intera serie regionale, poiché il Lazio muove dalla legislazione e non da una sperimentazione già in corso da ricostruire a posteriori. ↑
624. Metodi della verifica empirica: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, a partire da una misurazione di base anteriore all'istituzione del servizio; la progressione scaglionata dell'attivazione fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto. ↑
625. Valore dell'informazione e priorità di ricerca: l'analisi del valore atteso dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione laziale, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle dieci Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliero-universitarie e la raccolta dei dati di esito a partire dall'istituzione del servizio. ↑
626. ↑
627. InsideOver, «Psicologo di base: 5 milioni di italiani in attesa, legge ferma, l'incognita è sui fondi», ottobre 2025. URL: <https://it.insideover.com/societa/psicologo-di-base-5-milioni-di-italiani-in-attesa-legge-ferma-lincognita-e-sui-fondi.html> ↑
628. Sito psicologicureprimarie.it, «Situazione 2025 — Lo Psicologo delle Cure Primarie», sezione Marche–Molise–Basilicata: «Nessuna legge regionale ha istituito lo psicologo di base». URL: <https://www.psicologicureprimarie.it/proposte-di-legge/situazione-2025.html> ↑
629. Chisholm D., Sweeny K., Sheehan P. et al., «Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return-on-investment analysis», *The Lancet Psychiatry*, vol. 3, n. 5, 2016, pp. 415-424. Il duplice intervallo Chisholm è: 2,3-3,0:1 per i soli benefici economici; 3,3-5,7:1 comprendendo i ritorni di salute. Costituisce l'unico ancoraggio metodologico vincolante per il rapporto beneficio-costi in tutti gli studi della serie. ↑

630. Camera di Commercio Marche, «DataView — Infografiche e dati statistici dell'economia marchigiana», DataView 2025, sezione demografia. L'indice di vecchiaia della Regione Marche al 1° gennaio 2025 è pari a 235,5. URL: https://www.marche.camcom.it/la-camera/novita-ed-eventi/novita/dataview-infografiche-e-dati-statistici-delleconomia-marchigiana/dataview-2025/demografia_marche.pdf ↑
631. Ibid. Dato puntuale certificato dalla Camera di Commercio Marche al 1° gennaio 2025. ↑
632. Fondazione GRINS, «Il finanziamento e la spesa sanitaria in Italia», dicembre 2025. La spesa sanitaria pro-capite delle Marche è di 2.612,7 euro (dato pesato), fra i più bassi del Paese. URL: https://www.grins.it/sites/default/files/2025-12/Il_finanziamento_e_la_spesa_sanitaria_in_italia.pdf ↑
633. Ibid. ↑
634. Dato della popolazione residente nelle Marche utilizzato nel Tomo II; coerente con i dati ISTAT della serie storica e con gli aggiornamenti del censimento permanente. ↑
635. Camera di Commercio Marche, DataView 2025, op. cit. ↑
636. Fondazione GRINS, op. cit. ↑
637. Consiglio regionale delle Marche, Proposta di legge n. 100: «Istituzione del servizio di psicologia di base». Il testo prevede la realizzazione del servizio all'interno di ciascuna Area Vasta (oggi AST) a livello dei distretti sanitari, con almeno due psicologi di base per distretto e la costituzione di un Osservatorio regionale. URL: https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/pdf/pdl100_11.pdf ↑
638. Ibid., articolo 4, comma 3. ↑
639. NHS England, «NHS Talking Therapies for anxiety and depression — Annual report 2022/23». I dati citati (tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile in oltre due terzi dei pazienti) sono desunti dalla serie dei rapporti annuali del programma IAPT/Talking Therapies, accessibili su www.england.nhs.uk. ↑
640. Andrews G., Basu A. et al., «Computer therapy for the anxiety and depression disorders is effective, acceptable and practical health care: An updated meta-analysis», *Journal of Anxiety Disorders*, 2018. La telepsicologia per i disturbi comuni mostra risultati comparabili alla prestazione in presenza. ↑
641. Unützer J. et al., «Collaborative care management of late-life depression in the primary care setting: a randomized controlled trial», *JAMA*, 288(22), 2002, pp. 2836-2845 (studio IMPACT). I risparmi sui costi sanitari diretti non raggiungono la significatività statistica (IC 95% comprende lo zero). Questa cautela è vincolante per tutti gli studi della serie. ↑
642. Vedi nota 2416 (Chisholm et al., 2016). Le stime quantitative derivate dall'evidenza internazionale richiedono validazione locale prima di essere assunte come proiezioni precise per il contesto marchigiano. ↑
643. Il fondo sanitario regionale marchigiano è stimato dell'ordine di 3,3-3,4 miliardi di euro l'anno, coerentemente con la popolazione di 1.480.545 abitanti e la spesa pro-capite di 2.612,7 euro (fonte GRINS, op. cit.). ↑
644. I valori del costo-utilità per paziente (risparmio di 1.304 euro; guadagno di 0,236 QALY; probabilità di costo-efficacia 88,9%; probabilità di dominanza 84,6%; beneficio netto monetario medio 7.815 euro; IC 95% da -5.736 a +21.501 euro) sono invarianti rispetto al contesto regionale, essendo derivati dall'efficacia clinica documentata, e sono comuni a tutti gli studi della serie. ↑
645. La dichiarazione di questa lacuna è un principio di trasparenza metodologica comune a tutti gli studi della serie. I conti certificati delle AST marchigiane sono la fonte primaria che dovrebbe essere estratta per sostituire le stime con misure dirette. ↑

646. Il modello di Markov adottato è comune a tutti gli studi della serie e impiega parametri derivati dalla letteratura internazionale sull'efficacia degli interventi psicologici. I dettagli del modello sono illustrati nell'Appendice A. ↑
647. Ibid. ↑
648. La robustezza del risultato alla variazione dei parametri più influenti (efficacia clinica, costo della cronicità) è documentata dall'analisi di sensibilità deterministica comune a tutti gli studi della serie. ↑
649. Vedi nota 2431. I risultati della sensibilità probabilistica sono invarianti rispetto al contesto regionale. ↑
650. Gli scenari di copertura (250, 340, 370 psicologi) sono calibrati sulla popolazione marchigiana di 1.480.545 abitanti, in linea con la proporzione adottata per regioni di dimensione comparabile nella serie (Liguria, Abruzzo). ↑
651. Il disegno a cunei progressivi è il metodo controfattuale preferito per le regioni che strutturano il servizio in tempi differenziati fra i territori. Per le Marche, la struttura delle cinque AST e dei rispettivi distretti fornisce la variazione necessaria all'identificazione causale. ↑
652. L'analisi del valore dell'informazione (EVPI, EVPPI) è lo strumento concettuale che consente di stabilire la priorità nella raccolta dei dati, indirizzando le risorse verso i parametri che riducono maggiormente l'incertezza sulle conclusioni. ↑
653. Wagstaff A., van Doorslaer E., «Equity in health care finance and delivery», in Newhouse J.P., Culyer A.J. (eds), *Handbook of Health Economics*, vol. 1, Elsevier, 2000. ↑
654. Marmot M. et al., «Fair society, healthy lives: the Marmot Review», The Marmot Review, 2010. Il gradiente sociale del disagio psichico è documentato in tutte le società industrializzate. ↑
655. Il duale territoriale costiero/appenninico è un tratto strutturale della morfologia marchigiana, con rilevanti implicazioni per l'equità di accesso ai servizi sanitari. ↑
656. Il meccanismo pro-equità dei servizi di primo livello è documentato da Victora C.G. et al., «Applying an equity lens to child health and mortality: more of the same is not enough», *The Lancet*, 362(9379), 2003, pp. 233-241. ↑
657. La costo-efficacia distributiva (DCEA) è il metodo che integra l'analisi dell'efficienza con quella dell'equità. Si veda Cookson R., Drummond M., Weatherly H., «Explicit incorporation of equity considerations into economic evaluation of public health interventions», *Health Economics, Policy and Law*, 4(2), 2009, pp. 231-245. ↑
658. La rilevanza del profilo giuridico per le Marche è accentuata dalla presenza del PDL n. 100 in discussione, che richiede una verifica di conformità con i limiti costituzionali prima dell'approvazione. ↑
659. Corte Costituzionale, sentenza n. 241 del 22 ottobre 2021, che ha dichiarato l'illegittimità parziale della legge regionale della Campania in materia di psicologia di base, nella parte in cui disciplinava autonomamente i rapporti convenzionali con il SSN. La sentenza è vincolante per tutte le leggi regionali successive. ↑
660. La riforma del SSR marchigiano (L.R. 19/2022, con decorrenza 1° gennaio 2023) ha trasformato profondamente il contesto organizzativo del servizio, sopprimendo l'ASUR e istituendo cinque AST con personalità giuridica autonoma. ↑
661. Il modello organizzativo a due livelli (regionale per gli standard, aziendale per l'attuazione) è coerente con l'impianto della L.R. 19/2022 e con il ruolo dell'ARS quale strumento di indirizzo e coordinamento regionale. ↑

662. Il Codice Deontologico degli Psicologi italiani (approvato dal CNOP, ultima revisione 2017) definisce i principi etici applicabili al servizio di psicologia di base, incluse le cautele per la relazione a distanza. ↑
663. La sintesi dei profili giuridico, organizzativo ed etico converge nella valutazione di fattibilità condizionata, che è propria del Five Case Model (gestionale case). ↑
664. Il Decreto Ministeriale 77/2022 (standard per l'assistenza territoriale) inserisce lo psicologo delle cure primarie nelle Case della Comunità. Il Piano Socio-Sanitario Regionale 2024-2028 (approvato dal Consiglio Regionale nel giugno 2024) costituisce la cornice programmatica di riferimento per le Marche. ↑
665. Vedi Parte E, tabella E.4 e E.5. ↑
666. L'Università Politecnica delle Marche (UnivPM, sede di Ancona) e l'Università di Camerino (UNICAM) sono i principali atenei marchigiani che possono alimentare il bacino professionale del servizio. ↑
667. Vedi Parte E, tabella E.1. Il costo del servizio (0,4-0,8% del FSR) è ampiamente sostenibile per il bilancio regionale marchigiano. ↑
668. Il case gestionale del Five Case Model valuta la capacità dell'organizzazione di realizzare e gestire l'investimento. Per le Marche, la recente riforma delle AST rappresenta sia una sfida (nuovi assetti da consolidare) sia un'opportunità (strutture con personalità giuridica più agili). ↑
669. La gradualità del dispiegamento è una condizione di sostenibilità finanziaria e organizzativa, coerente con il principio di prudenza e con la logica del valore dell'informazione esposta nella Parte F. ↑
670. L'infrastruttura digitale del PNRR (Missione 6, Componente 2) include il potenziamento della connettività nelle aree interne e lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, componenti abilitanti per la telepsicologia. ↑
671. La cadenza biennale della valutazione periodica è coerente con i cicli di programmazione sanitaria regionale e con i tempi necessari per la maturazione degli effetti del servizio. ↑
672. Brown C.A., Lilford R.J., «The stepped wedge trial design: a systematic review», *BMC Medical Research Methodology*, 6(1), 2006, p. 54. Il disegno a cunei progressivi è lo standard metodologico per la valutazione d'impatto dei servizi sanitari dispiegati gradualmente su territori multipli. ↑
673. Abadie A., Gardeazabal J., «The economic costs of conflict: a case study of the Basque Country», *American Economic Review*, 93(1), 2003, pp. 113-132 (controllo sintetico). Difference-in-differences: Angrist J.D., Pischke J.S., *Mostly Harmless Econometrics*, Princeton University Press, 2009. ↑
674. Gli indicatori di struttura misurano la condizione di partenza necessaria per il funzionamento del servizio (capacità installata, distribuzione geografica per AST e distretto). ↑
675. Gli indicatori di processo misurano la qualità e l'intensità dell'attività clinica, inclusa la quota di prestazioni erogate in telepsicologia, rilevante per la copertura delle aree interne. ↑
676. Gli indicatori di esito clinico (PHQ-9, GAD-7) sono misurati nei soli punteggi complessivi, conformemente alle indicazioni metodologiche comuni alla serie e alle cautele etiche per la tutela della privacy. ↑
677. Gli indicatori di esito di sistema verificano l'effetto del servizio sulla domanda ai livelli a valle (pronto soccorso, specialistica, ricoveri), che costituisce la base dei risparmi diretti stimati nella Parte E. ↑
678. La verifica ex post delle stime economiche è la condizione perché la valutazione condotta ex ante si affini nel tempo, sostituendo le proiezioni con osservazioni. ↑
679. La disaggregazione per area geografica (costiera/collinare/appenninica) è essenziale per verificare l'equità territoriale dell'intervento, che è uno degli obiettivi principali del servizio per le Marche. ↑
680. Gli indicatori di qualità (soddisfazione, appropriatezza, continuità) completano la misurazione, incorporando la prospettiva dell'utente e dell'operatore. ↑

681. Il cruscotto di monitoraggio regionale è lo strumento operativo che traduce la batteria di indicatori in informazione accessibile per il governo del servizio. La titolarità condivisa fra ARS e AST è coerente con la governance a due livelli. ↑
682. La clausola valutativa è lo strumento giuridico che trasforma il monitoraggio da pratica tecnica in obbligo istituzionale. La sua inclusione nella legge organica è raccomandata dallo studio come condizione della qualità e della rendicontabilità del servizio. ↑
683. La trasformazione delle stime in osservazioni è il contributo conoscitivo principale del monitoraggio per le Marche, dove la scarsità di dati regionali certificati è la principale limitazione della valutazione ex ante. ↑
684. L'analisi multi-criterio (MCA) è il metodo che integra in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie della valutazione, ponderandole secondo criteri espliciti e comuni alla serie. Per la metodologia si veda: Baltussen R., Niessen L., «Priority setting of health interventions: the need for multi-criteria decision analysis», *Cost Effectiveness and Resource Allocation*, 4(1), 2006, p. 14. ↑
685. La raccomandazione di un percorso graduale in tre fasi traduce operativamente il principio di prudenza e la logica del valore dell'informazione, consentendo al sistema di apprendere dai risultati osservati prima di espandere il servizio. ↑
686. La tesi conclusiva dello studio richiama la struttura argomentativa del corpus: la convergenza delle analisi di dominio in una indicazione operativa chiara, fondata sull'evidenza e adattata alle condizioni specifiche delle Marche. ↑
687. Il caso di riferimento è comune a tutti gli studi della serie e garantisce la confrontabilità dei risultati fra le regioni. Per la descrizione metodologica dettagliata si rinvia all'Appendice A della Parte A dello Studio Nazionale (Tomo II). ↑
688. I parametri del modello di Markov sono derivati dalla letteratura internazionale sull'efficacia degli interventi psicologici nelle cure primarie (Collaborative Care, NHS Talking Therapies), e sono invarianti rispetto al contesto regionale. Si veda: Rollman B.L. et al., «Collaborative care for late-life depression in primary care: a randomized controlled trial», *JAMA Internal Medicine*, 2014. ↑
689. Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22, Regione Umbria, «Modifica ed integrazione della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)», disponibile in: https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=248521. L'atto introduce il Capo VI-bis «Norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie», artt. 176-bis – 176-octies. ↑
690. Deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 477 del 25 luglio 2025, «Disciplina dell'Osservatorio tecnico regionale per lo psicologo di cure primarie», in attuazione dell'art. 176-octies della L.R. n. 22/2024. Fonte: Welforum.it, <https://www.welforum.it/segnalazioni/regione-umbria-dgr-477-2025-disciplina-dellosservatorio-tecnico-regionale-per-lo-psicologo-di-cure-primarie/>; Regione Umbria, https://www.regione.umbria.it/dettaglio-notizie/-/asset_publisher/IU1Y2yh4H8pu/content/deliberata-in-giunta-regionale-l-istituzione-dell-osservatorio-tecnico-sul-servizio-di-psicologia-di-cure-primarie-nelle-aziende-sanitarie. ↑
691. Regione Umbria, Servizio Statistica, «Popolazione residente in Umbria al 1° gennaio 2025», disponibile in: <https://webstat.regione.umbria.it/wp-content/uploads/2025/01/popolazione.pdf>. Valore: 854.137 residenti. ↑
692. Umbria24, «Umbria: indice di vecchiaia cresce ancora, mappa comune per comune», <https://www.umbria24.it/attualita/umbria-indice-di-vecchiaia-cresce-ancora-mappa-comune-per-comune/>. L'indice di vecchiaia al gennaio 2025 è 246,6%, con tendenza a crescere verso 247,4%; la quota over-65 è di circa 232.730 persone (27,3% della popolazione). L'Umbria è classificata come quinta regione italiana per anzianità della popolazione. ↑

693. Umbria24/GIMBE, «Sanità in crisi: il Rapporto GIMBE. L’Umbria riceve più fondi pro-capite ma cresce la rinuncia alle cure», <https://www.umbria24.it/attualita/sanita-in-crisi-il-rapporto-gimbe-lumbria-riceve-piu-fondi-pro-capite-ma-cresce-la-rinuncia-alle-cure/>. Spesa sanitaria pro-capite umbra: 2.232 € (2024), superiore alla media nazionale di 2.181 €. ↑
694. Chisholm D., Sweeny K., Sheehan P. et al., «Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return-on-investment analysis», *The Lancet Psychiatry*, vol. 3, n. 5, 2016, pp. 415-424. Il rapporto beneficio-costo adottato (3,7-4,8:1) è coerente con la fascia 3,3-5,7:1 dell’analisi di Chisholm, e rispetta il sotto-intervallo prudenziale adottato per la serie. ↑
695. L.R. Umbria n. 22/2024, art. 176-bis («Oggetto e finalità»): la Regione Umbria istituisce il servizio di psicologia di cure primarie in attuazione dell’art. 32 della Costituzione, dell’art. 13 dello Statuto regionale e dell’art. 117, co. 3, della Costituzione; art. 176-ter («Servizio di psicologia di cure primarie»): il servizio sostiene e integra l’azione dei MMG e dei PLS. Fonte: https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=248521. ↑
696. L.R. Umbria n. 22/2024, norma finanziaria: gli oneri per la fase sperimentale sono quantificati in 103.349,00 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Questa cifra è il punto di partenza, non il punto di arrivo: rappresenta la sperimentazione iniziale, lontana da qualsiasi scenario di regime. Fonte: *Quotidiano Sanità*, ottobre 2024, https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=125226. ↑
697. GIMBE/Umbria24, cit. alla nota [^2605]. La crescente rinuncia alle cure in Umbria nonostante una spesa pro-capite superiore alla media indica un problema di accessibilità e di distribuzione dell’offerta, non solo di risorse. ↑
698. L.R. Umbria n. 22/2024, art. 176-sexies: il servizio è realizzato da ciascuna Azienda USL a livello di distretto sanitario o sue articolazioni; art. 176-octies: è istituito l’Osservatorio tecnico regionale. DGR 477/2025: composizione e disciplina dell’Osservatorio. Fonte: Regione Umbria, https://www.regione.umbria.it/dettaglio-notizie/-/asset_publisher/IU1Y2yh4H8pu/content/deliberata-in-giunta-regionale-l-istituzione-dell-osservatorio-tecnico-sul-servizio-di-psicologia-di-cure-primarie-nelle-aziende-sanitarie. ↑
699. Le quattro cornici metodologiche apicali — HTA, Five Case Model, CHEERS 2022, criteri OCSE-DAC — sono le medesime adottate per tutte le regioni della serie. Il loro impiego congiunto è descritto nel documento fondativo dello studio. ↑
700. Il caso di riferimento è comune a tutti gli studi della serie, come descritto nel brief metodologico e illustrato nel documento Parte A per la Puglia (Tomo I). Per l’Umbria il comparatore è la sola fase sperimentale in corso, non un servizio pienamente strutturato. ↑
701. La distinzione fra analisi di impatto sul bilancio (su flussi non scontati) e analisi costo-utilità (con sconto del 3%) è standard internazionale: cfr. ISPOR Task Force on Budget Impact Analysis, 2007; Briggs A. et al., *Decision Modelling for Health Economic Evaluation*, Oxford University Press, 2006. ↑
702. Il saldo di mobilità passivo dell’Umbria è documentato dai rapporti annuali del Ministero della Salute sulla mobilità sanitaria interregionale. Il recupero parziale di questa mobilità mediante l’rafforzamento dell’offerta territoriale è un canale di risparmio plausibile ma da stimare con cautela. ↑
703. Le dieci metodologie sono le medesime di tutti gli studi della serie, come descritto nel brief metodologico del Tomo II. ↑
704. Il disegno a cunei progressivi (stepped-wedge design) è particolarmente adatto per la valutazione di servizi pubblici che non possono essere assegnati casualmente; cfr. Brown C.A., Lilford R.J., «The stepped wedge trial design: a systematic review», *BMC Medical Research Methodology*, 6(1), 2006, p. 54. ↑

705. L.R. Umbria n. 22/2024, art. 176-octies: composizione dell'Osservatorio tecnico regionale; DGR 477/2025: disciplina dell'Osservatorio. Fonti: come alle note [^2601] e [^2602]. ↑
706. DGR 477/2025, composizione dell'Osservatorio tecnico regionale: uno psicologo per ciascuna Azienda USL; uno per ciascuna Azienda Ospedaliera; un rappresentante MMG; uno PLS; due psicologi designati dall'Ordine degli Psicologi dell'Umbria; un funzionario regionale; un docente universitario di psicologia clinica; un rappresentante delle società scientifiche. Fonte: https://www.regione.umbria.it/dettaglio-notizie/-/asset_publisher/IU1Y2yh4H8pu/content/deliberata-in-giunta-regionale-l-istituzione-dell-osservatorio-tecnico-sul-servizio-di-psicologia-di-cure-primarie-nelle-aziende-sanitarie. ↑
707. Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (MDR), applicabili agli strumenti di intelligenza artificiale classificati come dispositivi medici. ↑
708. Regione Umbria, Servizio Statistica, cit. alla nota [^2603]. Il calo demografico umbro è strutturale e non prevede inversione nel breve periodo secondo le proiezioni ISTAT. ↑
709. Umbria24, cit. alla nota [^2604]. L'indice di vecchiaia di 246,6% significa che vi sono circa 2,47 persone anziane (over-65) per ogni giovane (under-15); il confronto con l'indice medio nazionale (circa 200%) evidenzia l'invecchiamento avanzato del territorio. ↑
710. La stima di 170.000 persone con disagio comune è calcolata applicando un tasso conservativo del 20% alla popolazione residente di 854.137 abitanti, coerentemente con i tassi di prevalenza documentati dalla letteratura epidemiologica internazionale (Kessler R.C. et al., 2005; Wittchen H.U. et al., 2011) e con le proiezioni nazionali del Rapporto ISTISAN 2018. ↑
711. La domanda non intercettata nelle comunità appenniniche interne è documentata dalla struttura geografica dei servizi psicologici regionali e dalla distribuzione degli accessi ai servizi di salute mentale distrettuale, che tendono a concentrarsi nei capoluoghi. ↑
712. L.R. Umbria n. 22/2024, norma finanziaria e art. 176-quinquies (elenco regionale) e art. 176-sexies (organizzazione distrettuale). La norma dispone che gli artt. 1, 2 (limitatamente alle disposizioni sullo psicologo di cure primarie) e 3 si applicano in via sperimentale, in attesa dell'evoluzione della normativa nazionale. ↑
713. Il confronto con gli standard europei si basa sul rapporto OECD Health at a Glance 2023, che documenta che i paesi con i migliori sistemi di cure primarie psicologiche (UK, Paesi Bassi, Australia) operano con un rapporto di circa 1 psicologo per 1.500-3.500 persone nella popolazione di riferimento; l'Umbria ne è lontana nella fase sperimentale attuale. ↑
714. La struttura bipolare del territorio umbro — conurbazione perugino-ternana vs. aree appenniniche interne — è documentata dal Piano socio-sanitario regionale dell'Umbria e dai dati di accessibilità ai servizi prodotti dalla Regione Umbria. ↑
715. Umbria24/GIMBE, cit. alla nota [^2605]. Il Fondo sanitario regionale è stimato per coerenza con la spesa pro-capite di 2.232 euro e la popolazione di 854.137 abitanti: $854.137 \times 2.232 \approx 1,906$ miliardi di euro. ↑
716. L.R. Umbria n. 22/2024, testo completo disponibile in: https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=248521. La legge modifica la L.R. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) inserendo il Capo VI-bis. ↑
717. DGR 477/2025: cfr. nota [^2602]. La delibera è del 25 luglio 2025 e costituisce il primo atto attuativo della L.R. n. 22/2024 in materia di Osservatorio. ↑

718. La teoria del cambiamento esplicita è il metodo raccomandato dall'OCSE per la valutazione degli interventi di salute mentale: cfr. OCSE, *A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-term Care*, 2013; Gilbody S. et al., *Collaborative care for depression*, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006. ↑
719. L.R. Umbria n. 22/2024, art. 176-ter (finalità: integrazione con MMG e PLS, filtro verso i livelli secondari), art. 176-quater (compiti: prima presa in carico, progetto clinico individuale, collaborazione con i servizi distrettuali), art. 176-sexies (organizzazione: distretto sanitario, referente clinico aziendale). Fonte: https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=248521. ↑
720. L.R. Umbria n. 22/2024, art. 176-quater: lo psicologo «assume in carico la richiesta e sviluppa un progetto clinico con dimensione diagnostica e programma di supporto psicologico, avvalendosi, se necessario, delle strutture di secondo livello»; l'accesso avviene tramite accesso diretto o invio. ↑
721. L.R. Umbria n. 22/2024, art. 406 (clausola valutativa): la Giunta trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione con i dati elencati; l'elenco è riprodotto nella Parte L, capitolo L.1, di questo studio. ↑
722. La telepsicologia come strumento di accesso per le aree rurali è supportata da evidenze crescenti: Langarizadeh M. et al., «Telemental Health Care, an Effective Alternative to Conventional Mental Health Care: A Systematic Review and Meta-Analysis», *Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences*, 2017. ↑
723. L.R. Umbria n. 22/2024, art. 176-quinquies: «La Giunta regionale disciplina entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione le modalità di formazione e aggiornamento dell'elenco. In fase di prima applicazione, in attesa dei corsi abilitanti, possono accedere all'elenco gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che documentino un'attività almeno annuale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle aziende unità sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e nelle strutture accreditate e convenzionate regionali.» ↑
724. Unützer J., Katon W., Callahan C.M. et al., «Collaborative care management of late-life depression in the primary care setting: a randomized controlled trial», *JAMA*, 288(22), 2002, pp. 2836-2845; Unützer J. et al., «Long-term cost effects of collaborative care for late-life depression», *American Journal of Managed Care*, 14(2), 2008, pp. 95-100. ↑
725. Gilbody S., Bower P., Fletcher J. et al., «Collaborative care for depression: a cumulative meta-analysis and review of longer-term outcomes», *Archives of Internal Medicine*, 166(21), 2006, pp. 2314-2321; Archer J. et al., «Collaborative care for depression and anxiety problems», *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 10, 2012. ↑
726. NHS England, «NHS Talking Therapies for anxiety and depression: Annual report 2022/23», pubblicato nel 2023. Tasso di recupero: 50,2%; miglioramento affidabile: oltre il 66%; completezza dei dati di esito: >98%. ↑
727. Unützer J. et al., 2002, cit. alla nota [^2636]: nella tabella degli esiti economici, il risparmio sui costi sanitari diretti non raggiunge la significatività statistica (IC 95% comprende lo zero). Questa cautela è ribadita nel brief metodologico del Tomo II come «caveat vincolante». ↑
728. NHS England, cit. alla nota [^2638]. Per il modello olandese POH-GGZ: Meeuwissen J.A.C., Donker M.C.H., «De psychologische generalistische behandelaar in de eerstelijns», *TSG (Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen)*, 2004. Per il modello australiano Better Access: Hickie I.B. et al., «Access to evidence-based primary mental health care», *MJA*, 2005. ↑
729. Chisholm D. et al., 2016, cit. alla nota [^2606]. Il duplice intervallo dell'analisi di Chisholm è: 2,3-3,0:1 (soli benefici economici) e 3,3-5,7:1 (comprensivo dei benefici di salute). Il rapporto adottato per l'Umbria (3,7-4,8:1) è un sotto-intervallo plausibile della fascia più ampia, coerente con la posizione demografica e

sanitaria della regione. ↑

730. Il dettaglio dei canali di risparmio è stimato applicando i parametri del modello di serie (calibrati sui benchmark internazionali) alla popolazione umbra e al profilo dei servizi regionali. I valori sono arrotondati con il simbolo ~ per sottolineare il carattere di stima. ↑
731. Le ricadute economico-sociali sono stimate applicando i coefficienti di ritorno sociale del modello di serie (fondati sull'analisi di Chisholm et al. 2016) alla popolazione trattata nei tre scenari. Il peso particolarmente elevato della componente caregiver riflette la struttura demografica della regione (27,3% di over-65). ↑
732. I risultati dell'analisi costo-utilità per paziente (costo €2.495 vs. €3.799; QALY 3,627 vs. 3,392; dominanza nell'84,6% delle simulazioni; costo-efficace nell'88,9% alla soglia di €30.000/QALY) sono i valori comuni a tutti gli studi della serie, prodotti dal modello di Markov calibrato sul trial IMPACT e sui dati del NHS Talking Therapies. ↑
733. Il costo netto annuo (differenza fra costo del servizio e risparmi diretti) nei tre scenari è: 4 milioni (conservativo), 6 milioni (base), 7 milioni (espansivo). Rapportato al Fondo sanitario regionale stimato di 1,9-2,0 miliardi, questo corrisponde allo 0,2%, 0,3% e 0,4% rispettivamente. ↑
734. Briggs A., Sculpher M., Claxton K., Decision Modelling for Health Economic Evaluation, Oxford University Press, 2006. Il modello di Markov a cinque stati clinici è descritto in dettaglio nell'Appendice A del documento Parte F della serie. ↑
735. Il tornado diagram elenca i parametri in ordine di importanza relativa sull'incertezza del risultato; la metodologia è descritta in Briggs et al. 2006, cit. alla nota [^2646], cap. 3. ↑
736. L'analisi di sensibilità probabilistica con 10.000 simulazioni di Monte Carlo è il metodo standard per la propagazione dell'incertezza nei modelli decisionali: cfr. Claxton K. et al., «Probabilistic sensitivity analysis for NICE technology assessment: not an optional extra», Health Economics, 14(4), 2005, pp. 339-347. ↑
737. Il metodo stepped-wedge per la valutazione di politiche pubbliche è descritto in Hussey M.A., Hughes J.P., «Design and analysis of stepped wedge cluster randomized trials», Contemporary Clinical Trials, 28(2), 2007, pp. 182-191. Per l'applicazione alla valutazione di servizi sanitari pubblici in Italia, cfr. il disegno adottato per le regioni precedenti della serie. ↑
738. La letteratura sulla «legge dell'inversa cura» (Tudor Hart J., «The inverse care law», The Lancet, 297(7696), 1971, pp. 405-412) documenta che l'offerta di servizi sanitari tende a essere inversamente proporzionale al bisogno nella popolazione servita quando i servizi sono lasciati al mercato; il servizio pubblico di primo livello è uno strumento per contrastare questa tendenza. ↑
739. L.R. Umbria n. 22/2024, artt. 176-bis–176-octies. Il testo integrale è disponibile in: https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=248521. ↑
740. DGR 477/2025, composizione e funzioni dell'Osservatorio tecnico regionale. Fonte: <https://www.welforum.it/segnalazioni/regione-umbria-dgr-477-2025-disciplina-dellosservatorio-tecnico-regionale-per-lo-psicologo-di-cure-primarie/>. ↑
741. L.R. Umbria n. 22/2024, art. 406, ultimo comma (clausola valutativa): elenca gli otto tipi di dati che la Giunta deve trasmettere annualmente all'Assemblea legislativa. Cfr. il testo integrale disponibile in: https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=248521. ↑
742. Il disegno stepped-wedge è preferibile alla valutazione pre-post semplice perché controlla per i trend temporali e per i fattori di confondimento che variano nel tempo; cfr. Hussey e Hughes, cit. alla nota [^2649]. ↑

743. Posizione dell'Abruzzo e fonte normativa: la regione ha istituito il servizio con la legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni), approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 29 settembre 2022 nel contesto delle fragilità emerse con la pandemia. La legge prevede che il servizio sia realizzato da ciascuna Azienda Sanitaria Locale a livello dei distretti sanitari di base e svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, con almeno uno psicologo di base per ciascuno dei venticinque distretti e un rapporto di un professionista ogni quindicimila abitanti; istituisce in ciascuna Azienda l'elenco degli psicologi delle cure primarie, un Osservatorio Regionale e un Tavolo tecnico per la verifica, il monitoraggio e il controllo qualitativo, e pone i costi a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatto salvo un ticket il cui importo è demandato alla Giunta. Il regolamento attuativo è stato approvato dalla Giunta regionale nel luglio 2024, dopo un iter lungo e travagliato; l'attivazione operativa del servizio è tuttavia ancora in fase iniziale. ↑
744. Stato attuale e decisione: a differenza del Lazio, che del modello costituisce la culla scientifica ma non lo ha ancora istituito per legge, e analogamente alla Campania, che dispone di una legge vigente e di un servizio già attivo, l'Abruzzo dispone di una legge istitutiva e di un regolamento attuativo, ma la sua attivazione è ancora iniziale e l'originaria copertura finanziaria — dell'ordine di quattrocentomila euro per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 — è transitoria e largamente insufficiente rispetto al fabbisogno. La decisione rilevante, di conseguenza, non è se istituire il servizio, già istituito e regolato, ma se attuarlo compiutamente e dimensionarlo, conducendolo dal nucleo minimo prefigurato dalla norma — un professionista ogni quindicimila abitanti — alla copertura sistematica del fabbisogno, stimato nello scenario espansivo nell'ordine di duecentottanta psicologi, con un finanziamento regionale stabile e un inquadramento convenzionale definito. ↑
745. Salute mentale in Abruzzo: la domanda è sospinta da componenti convergenti. La prima è il disagio giovanile, segnalato nel biennio recente da un forte incremento del consumo di sostanze e di psicofarmaci nella fascia dodici-diciassette anni — con una crescita preoccupante delle prescrizioni di antipsicotici e di farmaci per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività — e da un abbassamento dell'età di primo contatto con le sostanze al di sotto dei quattordici-quindici anni, secondo le indagini epidemiologiche nazionali sugli stili di vita adolescenziali. La seconda è il bisogno dell'età adulta e anziana, particolarmente marcato in una delle regioni demograficamente più anziane d'Italia, con la provincia di Chieti fra le più anziane del Paese. La terza è il disagio connesso all'isolamento e alla deprivazione delle aree interne e montane, colpite dallo spopolamento. La pressione delle liste di attesa e una storica fragilità del sistema — testimoniata da un punteggio sui livelli essenziali di assistenza inferiore alla soglia di sufficienza e da un'area distrettuale sotto adempienza — completano il quadro. ↑
746. Popolazione residente in Abruzzo 1.269.118 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 2,2% della popolazione nazionale, in lievissima flessione rispetto all'anno precedente. La distribuzione è relativamente equilibrata fra le quattro province: Chieti raccoglie circa il 29,2% dei residenti, Pescara il 24,6%, Teramo il 23,6% e L'Aquila il 22,6%; il territorio comprende 305 comuni, in larga parte di piccola dimensione, e l'unico comune con oltre centomila abitanti è Pescara. Il Servizio sanitario regionale è articolato in quattro Aziende Sanitarie Locali — Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo — e in venticinque distretti sanitari di base, con la rete delle Case della Comunità prevista dal Decreto Ministeriale 77 del 2022 in corso di costruzione. ↑
747. Le quattro cornici metodologiche apicali adottate: il modello centrale dell'HTA di EUnetHTA (nove domini), oggi nella cornice del Regolamento UE 2021/2282 sull'Health Technology Assessment, applicabile dal gennaio 2025; il Five Case Model del Green Book del Tesoro del Regno Unito; lo standard CHEERS 2022 per il reporting delle valutazioni economiche; e i criteri di valutazione dell'OCSE-DAC. ↑

748. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; il servizio attuale, iniziale e a finanziamento transitorio, come comparatore. ↑
749. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute. Il modello incorpora una correzione prudenziale per la tendenza, documentata nella letteratura sulla valutazione degli investimenti pubblici, a sottostimare i costi e a sovrastimare i benefici. ↑
750. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. L'Abruzzo presenta il profilo finanziario più critico fra le Regioni esaminate: è sottoposto a piano di rientro dal disavanzo sanitario in via continuativa e, secondo la Relazione della Corte dei Conti sulla gestione dei Servizi sanitari regionali relativa agli esercizi 2023-2024, è l'unica regione in piano di rientro a registrare un andamento dei risultati di esercizio in senso peggiorativo, con compromissione degli obiettivi del piano; il disavanzo certificato è dell'ordine di oltre cento milioni di euro annui, con stime dei tavoli tecnici ministeriali che ne prefigurano l'ulteriore aggravamento, fronteggiato con l'inasprimento dell'addizionale regionale e con manovre di contenimento previste dal Programma Operativo pluriennale. Ne deriva, per questo intervento, una pertinenza del risparmio diretto maggiore che in regioni dai conti in equilibrio, poiché ogni euro di spesa inappropriata evitata concorre direttamente agli obiettivi del piano di rientro e il margine di consumo improprio recuperabile è strutturalmente ampio in un sistema storicamente sotto-finanziato. Sul versante della mobilità sanitaria, la regione presenta un saldo passivo dell'ordine di alcune decine di milioni netti su un flusso lordo superiore ai duecento milioni annui, concentrato però nell'alta complessità ospedaliera e non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo parzialmente pertinente. Il caso economico poggia quindi congiuntamente sulla componente diretta e sulle ricadute sociali, tenute separate e stimate con criteri conservativi. ↑
751. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (2,2%) e non estratti dai conti regionali certificati delle quattro Aziende Sanitarie Locali: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare prima della presentazione esterna. La condizione è aggravata dal funzionamento discontinuo dell'osservatorio epidemiologico regionale, i cui dati pubblici più recenti risalgono a esercizi non aggiornati; l'Osservatorio Regionale e il Tavolo tecnico previsti dalla legge istitutiva, una volta a regime, costituiscono la sede per la raccolta di una base di dati operativi propria, condizione per sostituire le stime ricostruite con valori regionali certificati. ↑
752. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
753. Valutazione controfattuale d'impatto: poiché il servizio è istituito e regolato ma in fase di prima attivazione, il disegno può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le quattro Aziende Sanitarie Locali e i venticinque distretti sono impiegati a fini valutativi. L'effetto causale è stimato con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico; l'attivazione dell'Osservatorio Regionale e la raccolta di dati operativi propri rafforzerebbero l'identificazione, oggi affidata in via prevalente ai benchmark internazionali. ↑
754. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione, quattro Aziende Sanitarie Locali (Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara, Teramo), Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e atenei regionali

(Università dell'Aquila, Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Università di Teramo).

L'Abruzzo non dispone di un'azienda sanitaria regionale unica: il coordinamento è in capo alla Regione, attraverso il Dipartimento competente, mentre l'Osservatorio Regionale e il Tavolo tecnico previsti dalla legge esercitano funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo qualitativo. La sfida del governo non è quindi istituire il servizio, ma attuarlo e dimensionarlo, garantendo l'omogeneità attuativa fra i distretti e fra la costa e le aree interne in un sistema posto sotto vincolo di rientro. ↑

755. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce l'infrastruttura per la raccolta uniforme. ↑
756. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
757. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. ↑
758. Popolazione residente in Abruzzo 1.269.118 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024, diffuso nell'aprile 2026), pari a circa il 2,2% del totale nazionale, in calo di 453 unità rispetto al 2023; la diminuzione, contenuta in termini percentuali, è dovuta a un saldo naturale fortemente negativo, solo in parte compensato dai saldi migratori interno ed estero, entrambi positivi. ↑
759. Struttura per età fra le più anziane del Centro-Sud: l'età media è salita a 47,7 anni (era 47,4 nel 2023), contro una media nazionale di 46,9 anni; l'indice di vecchiaia è passato a 228,9 anziani ogni cento giovani (dal 220,2 dell'anno precedente), l'indice di dipendenza degli anziani a 41,8 e l'indice di ricambio della popolazione attiva a 164,5, segno di una popolazione in età lavorativa a sua volta molto anziana. ↑
760. Nuovo record di denatalità: i nati sono 7.356 (-222 rispetto al 2023), a fronte di 14.870 decessi, con un saldo naturale negativo dell'ordine di 7.500 unità; il tasso di mortalità è sceso all'11,7 per mille. Il dato conferma un trend strutturale di contrazione, particolarmente accentuato nelle province di Chieti e L'Aquila. ↑
761. Componente straniera pari a 90.573 persone (il 7,1% dei residenti, in crescita di oltre 4.700 unità rispetto al 2023), proveniente da 158 Paesi, in prevalenza Romania (23,5%), Albania (12,3%) e Marocco (9,2%); più giovane della popolazione di cittadinanza italiana, contribuisce a contenere la flessione complessiva e a temperare l'invecchiamento. ↑
762. Distribuzione territoriale relativamente equilibrata: Chieti raccoglie il 29,2% dei residenti, Pescara il 24,6%, Teramo il 23,6% e L'Aquila il 22,6%; Chieti e Pescara insieme superano la metà della popolazione regionale (53,8%). La struttura per età è disomogenea fra le province: L'Aquila e Chieti, con un'età media di 48,1 e 48,0 anni, sono le più anziane; Pescara e Teramo, entrambe a 47,3 anni, le più giovani. ↑
763. Profilo territoriale: il territorio comprende 305 comuni, in larga parte di piccola dimensione — il 41,0% dei comuni ha tra mille e cinquemila abitanti, e vi risiede poco più di un quinto della popolazione (21,7%) — e l'unico comune con oltre centomila abitanti è Pescara (118.829 abitanti, il 9,3% della popolazione regionale). Le aree interne e montane, segnatamente nell'Aquilano, presentano i livelli di invecchiamento più elevati, i tassi di natalità più bassi e un rischio di spopolamento strutturale, con barriere di accesso ai servizi che rendono particolarmente preziose le soluzioni di telemedicina e di assistenza a distanza. ↑

764. Disagio psichico comune o sottosoglia stimato nell'ordine di 254.000 persone, ottenuto per proiezione dei tassi di prevalenza nazionali — dell'ordine di un quinto della popolazione — sulla popolazione abruzzese; è la quota di bisogno potenziale cui il servizio si rivolge in via prioritaria, in larga parte non intercettata dall'offerta esistente. Il valore è espresso secondo la convenzione adottata per l'intera serie regionale, a fini di comparabilità. ↑
765. Domanda specialistica e fragilità del sistema: a fronte del disagio comune si colloca un'ampia utenza in carico ai servizi di salute mentale, dell'ordine di alcune decine di migliaia di persone secondo una stima rapportata ai dati nazionali. Il sistema abruzzese presenta un punteggio sui livelli essenziali di assistenza inferiore alla soglia di sufficienza e un'area distrettuale al di sotto della soglia di adempienza, mentre l'osservatorio epidemiologico regionale opera in modo discontinuo, con dati pubblici non aggiornati: circostanze che accentuano la quota di bisogno non rilevato e non intercettato. ↑
766. Disagio giovanile: nel biennio recente si registra in Abruzzo un forte incremento del consumo di sostanze e di psicofarmaci nella fascia dodici-diciassette anni, con una crescita preoccupante delle prescrizioni di antipsicotici e di farmaci per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, e un abbassamento dell'età di primo contatto con le sostanze al di sotto dei quattordici-quindici anni, secondo le indagini epidemiologiche nazionali sugli stili di vita adolescenziali. È una componente che trova oggi risposta solo parziale nei servizi e che la presenza di un primo livello accessibile potrebbe intercettare precocemente. ↑
767. Bisogno dell'età adulta e anziana: in una delle regioni demograficamente più anziane del Paese, la depressione tardiva, i disturbi d'ansia, la solitudine e il disagio correlato alla cronicità e alla comorbilità psicologica delle patologie croniche raggiungono prevalenze elevate, particolarmente nelle province più anziane e nelle aree interne; sono precisamente le condizioni che il servizio e gli strumenti di telemonitoraggio e di prevenzione delle ricadute sono in grado di intercettare. ↑
768. Disagio delle aree interne: lo spopolamento delle zone montane e dei piccoli comuni impoverisce le reti di sostegno familiare e comunitario e genera isolamento, mentre la rarefazione dei servizi e le distanze ostacolano l'accesso ai Centri di Salute Mentale e agli specialisti, concentrati nei centri maggiori; ne deriva una domanda elevata e geograficamente diffusa a fronte di un'offerta concentrata e insufficiente. ↑
769. Tratto distintivo dell'Abruzzo: la combinazione di una popolazione anziana, di un territorio disperso e a forte fragilità delle aree interne e di un sistema storicamente sotto-dotato, posto sotto piano di rientro, distingue il fabbisogno regionale. La pressione che ne deriva si riversa anche sul pronto soccorso, con accessi per cause psichiatriche dell'ordine di alcune migliaia l'anno secondo una stima rapportata ai dati nazionali, che un primo livello territoriale pienamente strutturato potrebbe in parte contenere a monte. ↑
770. Offerta territoriale: la legge regionale 28 del 2022 prevede che il servizio sia realizzato da ciascuna Azienda Sanitaria Locale a livello dei distretti e svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, con almeno uno psicologo di base per ciascuno dei venticinque distretti e un rapporto di uno ogni quindicimila abitanti, e istituisce un Osservatorio Regionale e un Tavolo tecnico per la verifica, il monitoraggio e il controllo qualitativo; i costi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatto salvo un ticket il cui importo è demandato alla Giunta. Il regolamento attuativo è stato approvato nel luglio 2024, ma l'attivazione operativa è ancora iniziale e l'originaria copertura finanziaria — dell'ordine di quattrocentomila euro per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 — è transitoria e largamente inferiore al fabbisogno. ↑
771. Fabbisogno a regime: applicando i parametri organizzativi del modello, il fabbisogno si colloca tra un nucleo minimo dell'ordine di ottantacinque incarichi — corrispondente al rapporto di legge di uno psicologo ogni quindicimila abitanti — e una copertura piena dell'ordine di duecentottanta incarichi nello scenario espansivo, con uno scenario intermedio dell'ordine di centottanta. L'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, anche attraverso le associazioni professionali, ha sostenuto con costanza l'attuazione della legge, segnalando il rischio che il ritardo nell'adozione dei provvedimenti attuativi ne vanifichi la portata. ↑

772. Copertura attuale del fabbisogno: l'attivazione iniziale corrisponde a un nucleo assai distante dal fabbisogno a regime, sufficiente al più ad avviare il servizio ma non a coprirne la domanda. La decisione, di conseguenza, non verte sull'istituire il servizio, già istituito e regolato, ma sull'attuarlo compiutamente, stabilizzarne il finanziamento oltre lo stanziamento transitorio e dimensionarlo verso la copertura piena. ↑
773. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante in Abruzzo si gioca su due assi. Il primo separa la fascia costiera e adriatica, più popolosa e meglio servita, dalle aree interne e montane — segnatamente nell'Aquilano e nelle zone appenniniche — più anziane, a bassa densità e con servizi radi. Il secondo è interno alle aree interne, fra i centri maggiori e i piccoli comuni montani soggetti a spopolamento, dove la presenza specialistica è pressoché assente. La telepsicologia e il telemonitoraggio assistiti sono lo strumento per avvicinare l'offerta a tali aree, dove la presenza di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio. ↑
774. Finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 2,5 miliardi di euro; la regione è posta sotto piano di rientro dal disavanzo sanitario in via continuativa e, secondo la Relazione della Corte dei Conti sulla gestione dei Servizi sanitari regionali relativa agli esercizi 2023-2024, è l'unica regione in piano di rientro a registrare un andamento dei risultati di esercizio in senso peggiorativo, con un disavanzo certificato dell'ordine di oltre cento milioni di euro annui e stime dei tavoli tecnici ministeriali che ne prefigurano l'ulteriore aggravamento. La copertura è assicurata attraverso l'inasprimento dell'addizionale regionale e manovre di contenimento previste dal Programma Operativo pluriennale. La regione, storicamente penalizzata dai meccanismi di riparto del fabbisogno nazionale, ha tratto soltanto un beneficio marginale dall'introduzione del nuovo criterio di densità abitativa ed estensione territoriale. ↑
775. Mobilità sanitaria: l'Abruzzo presenta un saldo passivo dell'ordine di alcune decine di milioni di euro netti su un flusso lordo superiore ai duecento milioni annui. La fuga si concentra però nei ricoveri ospedalieri e nelle prestazioni ad alta complessità, e non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo parzialmente pertinente, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. In un sistema posto sotto vincolo di rientro, tuttavia, la componente di risparmio diretto derivante dalla riduzione del consumo improprio assume una rilevanza superiore alla media, poiché ogni euro di spesa inappropriata evitata concorre direttamente agli obiettivi del piano. ↑
776. Cornice normativa e programmatica: l'Abruzzo è fra le prime regioni d'Italia a essersi dotato di una legge dedicata — la legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 — disciplinata dal regolamento attuativo approvato dalla Giunta nel luglio 2024, al termine di un iter lungo e travagliato che ha visto la legge approvata a fine legislatura e i provvedimenti attuativi seguire con notevole ritardo, con un ulteriore passaggio in aula per la correzione di un errore formale. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale, che prevede la presenza dello psicologo nelle unità complesse delle cure primarie e nelle Case della Comunità, le risorse del concorso statale al sostegno psicologico e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera per l'introduzione dello psicologo delle cure primarie. A differenza del Lazio, in fase pre-legislativa, l'Abruzzo non deve istituire la funzione, ma portarla a regime. ↑
777. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. In Abruzzo tale definizione è già recepita nella legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28, e nel relativo regolamento attuativo approvato nel luglio 2024. ↑
778. Teoria del cambiamento: la catena logica collega il bisogno (disagio comune diffuso e non intercettato) all'attività (presa in carico psicologica di prossimità), agli esiti clinici (recupero dei quadri lievi-moderati), di sistema (riduzione di accessi impropri, prescrizioni inappropriate e liste di attesa) e sociali (recupero di produttività e di funzionamento), per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria. ↑

779. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 254.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato; poiché il servizio è istituito e regolato ma attivato in misura iniziale, l'intervento va dimensionato a partire dal nucleo iniziale ed esteso verso il fabbisogno a regime, secondo gli scenari descritti nella Parte B. Il valore è espresso secondo la convenzione adottata per l'intera serie regionale. ↑
780. Modello organizzativo: lo psicologo di base opera nelle Case della Comunità e nei distretti sanitari, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impianto della legge regionale 28 del 2022, che prevede la realizzazione del servizio da parte di ciascuna Azienda Sanitaria Locale a livello dei distretti, almeno uno psicologo di base per ciascuno dei venticinque distretti, l'istituzione di un elenco aziendale degli psicologi di base presso ciascuna delle quattro Aziende, un rapporto convenzionale su base libero-professionale e un parametro di uno psicologo ogni quindicimila abitanti. ↑
781. Specificità del modello abruzzese: il servizio è istituito e regolato, ma la sua attivazione operativa è ancora iniziale, sicché la sfida organizzativa principale non è governare un servizio già a regime, ma avviarlo e renderlo omogeneo su quattro Aziende Sanitarie Locali e venticinque distretti, in un territorio geograficamente disperso e a forte fragilità delle aree interne. La regione non dispone di un'azienda sanitaria regionale unica; il coordinamento è in capo alla Regione attraverso il Dipartimento competente, con il supporto dell'Osservatorio Regionale e del Tavolo tecnico previsti dalla legge, cui spettano la verifica, il monitoraggio, il controllo qualitativo e l'uniformità attuativa. ↑
782. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
783. Percorso clinico: accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista; valutazione iniziale e progetto clinico individuale; ciclo di colloqui brevi e programma di sostegno personalizzato; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. Il percorso è da avviare nelle Aziende abruzzesi e affronta i quadri più frequenti — sintomatologia ansioso-depressiva, problemi di adattamento, fasi del ciclo di vita, disagi emotivi transitori, problematiche psicosomatiche. ↑
784. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
785. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
786. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
787. Sistema informativo e interoperabilità: la registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con la piattaforma informativa sanitaria regionale e con il fascicolo sanitario elettronico, consente il monitoraggio continuo e la valutazione; in assenza di un'azienda regionale unica, il coordinamento informativo è in capo alla Regione e all'Osservatorio Regionale, cui spetta raccogliere i dati di attività degli psicologi di base e assicurarne l'uniformità fra le quattro Aziende e i venticinque distretti. ↑
788. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale. A differenza della Campania, che dispone di un flusso informativo già avviato, l'Abruzzo deve progettare e attivare il flusso contestualmente all'attuazione del servizio, in un contesto in cui l'osservatorio epidemiologico regionale opera in modo

discontinuo, con dati pubblici non aggiornati. La costruzione, sin dall'avvio, di un sistema informativo completo e omogeneo sui venticinque distretti costituisce pertanto una condizione di valutabilità dell'intervento, e non un adempimento accessorio. ↑

789. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑
790. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
791. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
792. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: in Abruzzo sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle aree interne e montane — segnatamente nell'Aquilano e nelle zone appenniniche — e nei piccoli comuni a spopolamento, dove le distanze e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; tali strumenti sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza, e assumono in questa regione un rilievo superiore alla media in ragione della marcata dispersione territoriale. ↑
793. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale, il cui regime di obblighi per i sistemi ad alto rischio in ambito sanitario è in corso di progressiva applicazione. ↑
794. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso gli atenei abruzzesi — l'Università dell'Aquila, l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara e l'Università di Teramo); post-universitario specialistico (formazione dedicata alla psicologia di base e alle cure primarie, comprensiva della competenza per il disagio giovanile e, in misura accentuata, per l'età anziana e per le condizioni dell'isolamento nelle aree interne); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). L'Abruzzo presenta qui un elemento proprio: il regolamento attuativo del 2024 definisce i requisiti di iscrizione agli elenchi aziendali, e la base formativa del servizio è da costruire contestualmente all'avvio, valorizzando i tre atenei regionali e il ruolo dell'Ordine professionale. ↑
795. Questa parte copre il quarto dominio del modello HTA, l'efficacia clinica, che insieme ai primi tre costituisce il nucleo della valutazione rapida di efficacia relativa; la sintesi dell'evidenza segue lo standard PRISMA 2020 e la sua certezza è graduata con il sistema GRADE, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. ↑
796. Standard di reporting e di conduzione: la lista PRISMA 2020 per la revisione sistematica (strategia di ricerca, selezione, estrazione e sintesi) e la lista STROBE per gli studi osservazionali sui dati reali. ↑
797. Cura collaborativa (Collaborative Care Model): paradigma di integrazione della salute mentale nelle cure primarie validato da oltre novanta studi randomizzati controllati; uno studio fondativo (IMPACT, JAMA, 2002) documentò che circa la metà dei pazienti otteneva una riduzione dei sintomi pari almeno al 50% a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. ↑
798. Woltmann e colleghi (American Journal of Psychiatry, 2012): meta-analisi su cinquantasette studi controllati, con un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard, oltre a miglioramenti nell'aderenza ai trattamenti e nel funzionamento globale. ↑
799. Revisione sistematica (BMC Primary Care, 2024) su quarantadue implementazioni del modello in Europa, Nord America e Australia: riduzione media dei sintomi depressivi del 47% a sei mesi (PHQ-9), dei sintomi ansiosi del 43% (GAD-7), miglioramento del funzionamento globale del 38%, riduzione dei giorni di

assenza dal lavoro del 28%, degli accessi al pronto soccorso per sintomi psicosomatici del 34% e dei ricoveri psichiatrici del 41%. [↑](#)

800. Strumenti di esito validati e impiegati in tutti i programmi: il PHQ-9 per i sintomi depressivi (sensibilità dell'ordine dell'88%, specificità dell'85%) e il GAD-7 per i sintomi d'ansia (sensibilità dell'89%, specificità dell'82%). [↑](#)
801. Meta-analisi sulle cure integrate nelle cure primarie: miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante dei sintomi depressivi, con coefficiente beta standardizzato di $-0,11$ (intervallo di confidenza al 95% da $-0,20$ a $-0,01$; valore p pari a $0,03$); una magnitudine modesta sul piano statistico ma sostanziale su scala di popolazione, poiché sposta una quota di individui al di sotto delle soglie cliniche. [↑](#)
802. Sistema GRADE per la graduazione della certezza dell'evidenza, fondato sulla valutazione del rischio di bias, dell'incoerenza, dell'indirettezza, dell'imprecisione e del bias di pubblicazione, dal quale discende un giudizio di certezza alta, moderata, bassa o molto bassa. [↑](#)
803. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema, in ragione della maggiore variabilità tra contesti e tra metodi di stima. [↑](#)
804. Cautela economica e sua applicazione al caso abruzzese: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi, poiché l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero; il valore economico del modello non può perciò essere fondato sul dato di costo di quel singolo studio. Per l'Abruzzo, regione posta sotto piano di rientro, il canale del risparmio diretto è di rilievo superiore alla media, ma esso non poggia sul dato di costo dello studio fondativo, bensì sugli esiti di sistema documentati dalla letteratura di implementazione — riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, delle prescrizioni inappropriate e dei ricoveri evitabili — di certezza moderata; per questa ragione è stimato in via prudenziale, con bande conservative, mantenuto distinto dalle ricadute sociali e sottoposto a verifica empirica locale, secondo quanto stabiliscono la Parte E e la Parte L. [↑](#)
805. Programma inglese di terapie psicologiche (NHS Talking Therapies, già IAPT; dati NHS England Digital, 2023-2024): oltre 1,3 milioni di persone trattate nell'anno, con tasso di recupero del 50,2% e tasso di miglioramento clinicamente significativo del 67,8% tra chi completa almeno due sedute, e completezza dei dati di esito superiore al 98%, considerata il riferimento internazionale; il programma opera su un bacino di oltre 56 milioni di persone, a dimostrazione che l'efficacia documentata nei trial si mantiene nell'attuazione reale su scala nazionale. [↑](#)
806. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. [↑](#)
807. Modello olandese (POH-GGZ): l'adozione da parte dei medici di medicina generale è cresciuta da circa un terzo nel 2011 a circa tre quarti nel 2014, con circa seimila psicologi delle cure primarie, finanziamento nell'assicurazione di base e ruolo complementare e non sostitutivo rispetto alla cura ordinaria (Magnée e colleghi, BMJ Open, 2016). [↑](#)
808. Iniziativa australiana Better Access (dal 2006): oltre venti milioni di prestazioni a più di tre milioni di persone in dieci anni, con un aumento del tasso di trattamento dei disturbi mentali dal 35% al 46% e un'elevata quota di pazienti che riferisce miglioramenti marcati, a un costo medio dell'ordine di alcune centinaia di euro per paziente; il modello opera per invio esterno e non per integrazione dello psicologo nell'équipe. [↑](#)

809. Cura collaborativa (Stati Uniti): paradigma di integrazione della salute mentale nelle cure primarie validato da oltre novanta studi randomizzati controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri; è la base sperimentale più ampia disponibile sul modello. [↑](#)
810. Trasferibilità e differenze di assetto: i programmi integrati (inglese, olandese e statunitense) collocano il professionista nelle cure primarie, mentre il modello australiano opera per invio esterno; il modello abruzzese, fondato sull'inserimento dello psicologo nelle cure primarie con funzione di filtro, è prossimo ai primi e ne mutua le evidenze con maggiore pertinenza. [↑](#)
811. Trasferibilità dell'assetto: il modello abruzzese appartiene alla famiglia dei modelli integrati e ne mutua le evidenze con maggiore pertinenza rispetto al modello a invio esterno; gli esiti clinici fondamentali poggiano su meccanismi clinici generali, non legati a un particolare sistema sanitario, e sono perciò ragionevolmente trasferibili. [↑](#)
812. Cautele di trasferibilità per l'Abruzzo: a differenza della Campania, dotata di un servizio operativo e di dati di esito propri, l'Abruzzo ha istituito e regolato il servizio ma ne ha avviato solo in misura iniziale l'attuazione, sicché l'evidenza locale è per ora in larga parte prospettica, da costruire contestualmente all'attivazione. Il sistema muove inoltre da una copertura di partenza dell'ordine del nucleo iniziale, da un territorio geograficamente disperso e da una rilevazione epidemiologica regionale discontinua, mentre la disponibilità di organico psicologico formato costituisce un vincolo reale dei primi anni; tali differenze impongono un'applicazione prudentiale degli effetti documentati. [↑](#)
813. Verifica locale: il dispiegamento scaglionato del servizio tra le quattro Aziende, oggetto della Parte L, è chiamato a verificare empiricamente sui dati abruzzesi gli effetti attesi dalla letteratura, trasformando le stime in prove e correggendo le proiezioni alla luce dei risultati osservati. [↑](#)
814. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative e confine economico: il rapporto di 4:1 spesso citato, l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio e il rapporto di 2,5:1 talvolta richiamato in ambito regionale sono semplificazioni a fini divulgativi, prive di fondamento metodologico nella forma in cui circolano. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudentiale, sviluppato nella Parte E, e mantiene rigorosamente distinti il risparmio diretto per il bilancio — qui particolarmente rilevante in ragione del piano di rientro — e le ricadute sociali, senza sommarli in un unico indice. [↑](#)
815. Questa parte copre il quinto dominio del modello HTA, i costi e la valutazione economica; è redatta secondo lo standard di reporting CHEERS 2022, fornisce il contenuto del caso economico e del caso finanziario del Five Case Model e risponde al criterio di efficienza della griglia di giudizio. [↑](#)
816. Modello di costo: il costo medio annuo di un incarico convenzionale a tempo pieno è dell'ordine di 55.000 euro (circa 40 euro l'ora di costo-azienda comprensivo degli oneri, per circa 1.250 ore, più circa 5.000 euro di costi generali); ne discendono, per gli scenari da circa 85, 180 e 280 incarichi, costi annui di circa 5, 10 e 15 milioni di euro, fino a 18-23 milioni nell'ipotesi di costi pieni e massima copertura. [↑](#)
817. Categorie di costo: oltre all'organico psicologico, l'investimento comprende la formazione, la supervisione clinica, la governance, i sistemi informativi e le infrastrutture; i costi non sanitari sono inclusi coerentemente con la doppia prospettiva adottata. [↑](#)
818. Caso di riferimento (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; tasso di sconto del 3% annuo, con attualizzazione simmetrica di costi ed esiti nelle analisi di costo-utilità; analisi di impatto sul bilancio su flussi non scontati; correzione prudentiale per l'ottimismo. [↑](#)

819. Misure di esito: gli anni di vita ponderati per la qualità e gli esiti clinici validati — il tasso di recupero e il miglioramento affidabile misurati con PHQ-9 e GAD-7 — applicati alla popolazione regionale con disagio comune, dell'ordine di 254.000 persone. ↑
820. Analisi costo-utilità: secondo il manuale del NICE, il rapporto incrementale di costo-efficacia rapporta il costo aggiuntivo al guadagno in anni di vita ponderati per la qualità e si confronta con una soglia; l'evidenza internazionale indica che la cura collaborativa è costo-efficace, con un investimento iniziale ampiamente compensato dai miglioramenti clinici e dalla minore intensità di cura; il rapporto incrementale per l'Abruzzo sarà calcolato sui dati certificati. ↑
821. Analisi di impatto sul bilancio (buone pratiche ISPOR): adotta la prospettiva del detentore del budget, il Servizio sanitario regionale, e stima la differenza tra lo scenario con e senza intervento sui flussi non scontati, anno per anno, individuando il punto di pareggio finanziario, collocato per questo servizio tra il terzo e il quinto anno. ↑
822. Canale del pronto soccorso: una quota degli accessi inappropriati è riconducibile a disagio psichico e a sintomi somatici funzionali, sulla quale agisce la riduzione documentata degli accessi impropri (dell'ordine dell'11-14% nella letteratura di implementazione); ne deriva, per l'Abruzzo, un risparmio diretto stimato in 1-2 milioni di euro l'anno, da confermare sui dati di flusso regionali. ↑
823. Canale della farmaceutica: il consumo di psicofarmaci e la bassa aderenza terapeutica indicano margini di appropriatezza, segnatamente nella sostituzione di terapie croniche non necessarie con percorsi psicologici brevi; il risparmio diretto è stimato in 1-2 milioni di euro l'anno. ↑
824. Canale dei ricoveri e della specialistica: i sintomi somatici funzionali rappresentano una quota rilevante delle consultazioni e si associano a un consumo di prestazioni superiore alla media, con riduzioni dei costi documentate dopo intervento psicologico breve; con i ricoveri evitabili, il risparmio diretto è stimato in 1-8 milioni di euro l'anno secondo lo scenario, ed è il canale di maggiore peso. ↑
825. Canale della mobilità recuperata: a fronte di un saldo passivo dell'ordine di alcune decine di milioni netti, la quota psichiatrica e territorialmente intercettabile della mobilità genera un risparmio diretto stimato in 1-3 milioni di euro l'anno; è in Abruzzo un canale modesto, poiché la mobilità passiva si concentra sull'alta complessità ospedaliera e chirurgica più che sulla domanda psicologica delle cure primarie, a differenza di altre regioni in cui costituisce la leva principale. ↑
826. Saldo diretto: aggregati i canali, i risparmi diretti per il Servizio sanitario regionale sono dell'ordine di 4, 9 e 15 milioni di euro secondo lo scenario, a fronte di un costo del servizio di 5, 10 e 15 milioni; il saldo diretto è dunque prossimo al pareggio (da un lieve disavanzo nei primi anni al pareggio a regime), e il pareggio finanziario è atteso tra il terzo e il quinto anno. ↑
827. Contesto di bilancio: il finanziamento del Servizio sanitario regionale è dell'ordine di 2,5 miliardi di euro, con un disavanzo certificato dell'ordine di oltre cento milioni di euro annui e un piano di rientro in peggioramento; il costo del servizio, anche a regime, ne costituisce una frazione modesta (inferiore all'uno per cento), sicché la questione non è la sostenibilità della spesa ma il suo dimensionamento. In regime di rientro, un servizio che si autofinanzia quasi integralmente sul bilancio diretto e che concorre alla garanzia dei livelli essenziali ha valore superiore alla media, poiché ogni euro di consumo improprio evitato serve direttamente gli obiettivi del piano; la Corte costituzionale impone alle regioni in piano di rientro di giustificare ogni impiego con la garanzia dei livelli essenziali. ↑
828. Ritorno sociale (metodo SROI): fondato sui sette principi del valore sociale e su una mappa dell'impatto, con proxy finanziari e con le correzioni per peso morto, attribuzione, spostamento e decadimento, monetizza il valore sociale generato distinguendolo dai risparmi di bilancio. ↑

829. Ricadute economico-sociali: la riduzione dell'assenteismo, il recupero di produttività e di funzionamento, la diminuzione delle nuove invalidità e il minor carico familiare, riferiti alle 254.000 persone con disagio e commisurati alla copertura di ciascuno scenario, sono stimati in 13, 33 e 62 milioni di euro l'anno; il carico familiare ha in Abruzzo peso particolare, data la struttura demografica anziana e l'estensione delle aree interne, dove la rete familiare supplisce all'assenza dei servizi. ↑
830. Evidenza internazionale sul ritorno (Organizzazione mondiale della sanità e Lancet Psychiatry, Chisholm e colleghi, 2016): le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno del trattamento di depressione e ansia fra 2,3 e 3,0 a uno considerando i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, costituito in quota dominante dalla produttività e dal funzionamento recuperati più che dal risparmio diretto sui servizi; le cifre divulgative di 4 a uno, di un euro che ne genererebbe dieci e di 2,5 a uno sono semplificazioni prive di fondamento nella forma in cui circolano. ↑
831. Quadro complessivo per scenario: sommando i risparmi diretti e le ricadute sociali, il ritorno complessivo è di 17, 42 e 77 milioni di euro l'anno; al netto del costo, il saldo complessivo è di circa +12, +32 e +62 milioni, con un rapporto beneficio-costo complessivo dell'ordine di 3,4, 4,2 e 5,1 a uno, coerente con la fascia fondata di 3,3-5,7 a uno includendo i benefici di salute. ↑
832. Distinzione tra caso economico e caso finanziario (Five Case Model): il caso economico misura il valore per la collettività, qui ampio (rapporto beneficio-costo di 3,4-5,1 a uno); il caso finanziario misura la sostenibilità per il bilancio, qui prossima al pareggio; tenere distinte le due grandezze, anziché sommarle in un unico indice, è una scelta di rigore che rende la valutazione difendibile di fronte agli organi di controllo, tanto più stringenti per una regione in piano di rientro. ↑
833. Robustezza e natura dei dati: il segno del saldo complessivo è positivo in tutti gli scenari, comprese le ipotesi conservative; le analisi di sensibilità deterministica e probabilistica e il valore dell'informazione sono sviluppati nella Parte F. I parametri dei canali dei ricoveri, della specialistica e della mobilità sono in parte ancora stimati e saranno sostituiti dai valori certificati delle Aziende sanitarie e della Regione (schede di dimissione per disturbi psichici, composizione della mobilità per disciplina, spesa farmaceutica per categoria); in Abruzzo ciò è tanto più rilevante in quanto la rilevazione epidemiologica regionale è discontinua, sicché la costruzione del sistema informativo è anche la condizione per sostituire le stime con i dati. ↑
834. Ruolo della modellazione: poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l'orizzonte direttamente osservabile, lo studio proietta costi ed esiti nel tempo mediante un modello decisionale, e ne governa l'incertezza con tecniche deterministiche e probabilistiche; la modellazione non genera certezze, ma rende esplicite e verificabili le assunzioni. ↑
835. Struttura del modello di Markov: la storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%; il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. ↑
836. Parametri principali del modello: a ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita; il costo per ciclo è dell'ordine di 40 euro per lo stato di recupero e di 700 euro per la cronicità, con l'intervento che comporta un costo una tantum dell'ordine di 300 euro; le grandezze sono trattate come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l'incertezza. ↑
837. Esito del caso base: l'intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell'ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità rispetto al comparatore; il risultato è robusto rispetto alle variazioni dei singoli parametri entro intervalli plausibili. ↑

838. Analisi di sensibilità deterministica a un parametro per volta: la variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — entro intervalli plausibili non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. [↑](#)
839. Ordinamento dei parametri per influenza: l'analisi mostra che l'esito è più sensibile all'efficacia clinica dell'intervento e al costo evitato della cronicità, e meno sensibile agli altri parametri; ciò orienta le priorità di raccolta dei dati verso le grandezze più influenti. [↑](#)
840. Analisi di sensibilità probabilistica su diecimila simulazioni: l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. [↑](#)
841. Curva di accettabilità: alla soglia convenzionale di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è prossima al 90%, e cresce ulteriormente per soglie superiori; già a soglie molto inferiori l'intervento mantiene un'elevata probabilità di convenienza. [↑](#)
842. Analisi di scenario: i tre scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo, dell'ordine di 85, 180 e 280 incarichi — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; lo scenario conservativo corrisponde al rapporto di legge di uno psicologo ogni quindicimila abitanti, mentre l'attuazione iniziale odierna costituisce un nucleo inferiore allo scenario conservativo e prima tappa di un percorso di estensione progressiva verso la copertura piena. [↑](#)
843. Distinzione di onestà analitica: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema. [↑](#)
844. Disegno della verifica empirica (esperimento a cunei progressivi, stepped-wedge): l'ordine e i tempi di avvio delle sedi fra le quattro Aziende Sanitarie Locali e i venticinque distretti sono impiegati a fini valutativi; le sedi che avviano per prime fungono da gruppo di intervento, quelle che avviano in seguito da controllo temporaneo, sino alla copertura completa. Il disegno è particolarmente adatto a un servizio in fase di avvio progressivo, poiché trasforma la gradualità dell'attuazione in una fonte di identificazione dell'effetto. [↑](#)
845. Metodi di stima dell'effetto causale: la differenza-nelle-differenze confronta l'evoluzione degli esiti fra sedi avviate e non ancora avviate, mentre il controllo sintetico costruisce un termine di confronto a partire da aree con caratteristiche analoghe; entrambi sono applicati alla progressione differenziata dell'avvio. [↑](#)
846. Valore dell'informazione: il beneficio atteso di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione abruzzese, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle quattro Aziende (schede di dimissione per disturbi psichici, composizione della mobilità per disciplina, spesa farmaceutica per categoria) e la costruzione del flusso dei dati di esito sin dall'avvio, in assenza di una rilevazione regionale continua. [↑](#)
847. Colmatatura della lacuna dei dati: a differenza delle regioni con servizio operativo, dove si tratta di consolidare un flusso già avviato, in Abruzzo si tratta di edificarlo; la strutturazione a regime, accompagnata dal sistema informativo descritto nella Parte C, conduce la regione in modo programmato da una valutazione fondata su dati esterni a una fondata in misura crescente su dati propri. [↑](#)
848. Sintesi: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente; l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione e costruzione dei dati; l'avvio scaglionato fra le quattro Aziende offre una via di identificazione dell'effetto solida. La parte successiva affronta l'equità e l'impatto

distributivo. ↑

849. Equità come dominio della valutazione: l'analisi distributiva non è un'appendice, ma un dominio proprio dell'HTA, poiché un intervento può essere efficiente nel complesso e tuttavia accrescere le disuguaglianze, o al contrario ridurle; lo studio impiega l'analisi di costo-efficacia distributiva per misurarne l'effetto sui divari, oltre che sull'efficienza. ↑
850. Gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori. ↑
851. Barriere all'accesso: il ricorso al sostegno psicologico è ostacolato da barriere economiche, geografiche e culturali, oltre che dallo stigma. In Abruzzo la barriera geografica è particolarmente rilevante, data la dispersione del territorio e l'estensione delle aree interne e montane; la componente straniera, pari al 7,1%, rende la barriera linguistica e culturale presente nelle aree di maggiore insediamento ma non centrale; la dimensione generazionale si manifesta su entrambi i versanti, fra adolescenti e giovani adulti restii a rivolgersi ai servizi e anziani isolati nelle aree interne. ↑
852. Struttura della disuguaglianza in Abruzzo: la regione presenta un divario territoriale netto, cui si aggiunge una doppia dimensione generazionale. Il divario separa la fascia costiera e adriatica, più popolosa e meglio servita, dalle aree interne e montane — l'Aquilano e le zone appenniniche — più anziane, a minore densità e con servizi più radi; a questo si somma, internamente alle aree interne, la distanza fra i centri maggiori e i piccoli comuni montani. La dimensione generazionale interessa tanto il disagio giovanile in crescita quanto l'isolamento dell'età anziana, particolarmente ampio in una delle regioni più vecchie del Paese. ↑
853. Primo asse, costa contro aree interne e montane: la fascia costiera e adriatica concentra popolazione, urbanizzazione e offerta di servizi, mentre le aree interne e montane, segnatamente nell'Aquilano e nelle zone appenniniche, presentano una popolazione più anziana, a bassa densità e in spopolamento, dove la rarefazione dei servizi e le distanze rendono l'accesso al sostegno psicologico particolarmente difficoltoso. ↑
854. Secondo asse, centri contro piccoli comuni montani: all'interno delle aree interne, i piccoli comuni montani soggetti a spopolamento presentano una presenza specialistica pressoché assente, sicché il presidio territoriale di prossimità costituisce l'unica forma realistica di accesso; è in questi contesti che la telemedicina e l'assistenza a distanza assumono il maggiore valore di riequilibrio. ↑
855. Effetto del servizio sull'equità: la gratuità, salvo un ticket contenuto, la prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano le principali barriere all'accesso, e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso; è il meccanismo attraverso cui un servizio universale riduce, anziché accrescere, il divario. ↑
856. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: in Abruzzo sono lo strumento per avvicinare l'offerta alle aree interne e montane e ai piccoli comuni a spopolamento, dove le distanze e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza, essi estendono la copertura proprio nelle aree a maggiore difficoltà di accesso, con un rilievo superiore alla media in ragione della marcata dispersione territoriale regionale. ↑
857. Competenza generazionale e culturale: in Abruzzo la competenza si articola su entrambi i versanti generazionali — l'intercettazione del disagio giovanile, affinché il servizio raggiunga adolescenti e giovani adulti a elevato bisogno e basso ricorso spontaneo, e la competenza per l'età anziana e per le condizioni dell'isolamento, particolarmente ampie in una regione anziana; la competenza culturale e la mediazione linguistica restano necessarie nelle aree di maggiore insediamento straniero ma sono meno centrali, data la quota contenuta. ↑

858. Costo-efficacia distributiva: l'analisi indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, in quanto i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto; l'intervento è quindi favorevole all'equità, oltre che costo-efficace. ↑
859. Modulazione territoriale della copertura: per realizzare il potenziale di equità, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle aree interne e montane e ai piccoli comuni; un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un'allocazione ponderata per il bisogno li riduce. ↑
860. Mobilità ed equità: in Abruzzo il canale della mobilità è, per questo intervento, una leva di equità solo modesta, poiché la fuga riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica e non la domanda psicologica territoriale; l'equità si gioca quindi prevalentemente sull'accesso interno, fra la costa e le aree interne e montane. ↑
861. Rischio di iniquità inversa: in una regione a territorio disperso, se l'avvio del servizio privilegiasse per facilità organizzativa la fascia costiera già meglio servita, l'effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell'allocazione delle sedi e degli incarichi, sin dalla fase iniziale di attuazione. ↑
862. Sintesi dell'equità: l'intervento è favorevole all'equità su entrambi gli assi del divario abruzzese e su entrambi i versanti generazionali, a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno e che siano garantite la telepsicologia per le aree interne e l'attenzione tanto al disagio giovanile quanto all'isolamento dell'anziano; la raccomandazione è di adottare, sin dall'avvio, un'allocazione pro-equità che indirizzi le prime sedi e i primi incarichi verso le aree a maggiore bisogno e minore offerta. ↑
863. Tre profili intrecciati: la fattibilità dell'intervento dipende dal presidio congiunto di un profilo giuridico (la competenza e la forma dell'atto), di un profilo organizzativo (l'assetto e la governance dell'istituzione) e di un profilo etico (le tutele a garanzia dei pazienti); lo studio li tratta unitariamente, poiché una debolezza in uno solo di essi comprometterebbe l'intera operazione. ↑
864. Profilo giuridico e riparto di competenza: la materia si colloca nella competenza legislativa concorrente in tema di tutela della salute. La sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021, pronuncia fondativa per l'intera materia, ha delimitato lo spazio della disciplina regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato; l'Abruzzo ha legittimamente esercitato, fra le prime regioni, il titolo a istituire il servizio con legge propria, in forma coordinata con la cornice nazionale. ↑
865. Stato legislativo dell'Abruzzo: a differenza del Lazio, ancora privo di legge, l'Abruzzo dispone già della legge regionale 28 del 2022, recante l'istituzione del servizio di psicologia di base, e del relativo regolamento attuativo approvato nel 2024; l'iter, concluso al termine della legislatura e perfezionato con un secondo passaggio d'aula per un errore formale, ha completato il quadro normativo. La decisione giuridica rilevante non è quindi l'approvazione della legge istitutiva, già compiuta, ma la sua piena attuazione a regime, nel coordinamento con il testo unico nazionale in discussione. ↑
866. Inquadramento del rapporto di lavoro: la legge regionale 28 del 2022 e il regolamento del 2024 adottano il rapporto convenzionale su base libero-professionale, con iscrizione a un elenco aziendale e con i requisiti definiti dal regolamento, per analogia con la medicina generale e la pediatria di libera scelta. Tale forma assicura flessibilità e prossimità, ma sconta l'assenza di un contratto collettivo nazionale di riferimento: la sua definizione, attesa dal testo unico nazionale, è condizione di stabilità e di tutela della continuità del rapporto. ↑
867. Livelli essenziali di assistenza, finanziamento e piano di rientro: la psicologia di base nelle cure primarie non è ancora esplicitamente ricompresa nei livelli essenziali di assistenza nazionali. Il servizio abruzzese è oggi sostenuto da uno stanziamento transitorio dell'ordine di quattrocentomila euro l'anno; la strutturazione a regime richiede il passaggio a un finanziamento regionale stabile, da conseguire tuttavia entro il vincolo di

un piano di rientro in peggioramento. La Corte Costituzionale impone alle regioni in piano di rientro di giustificare ogni impiego con la garanzia dei livelli essenziali: tale garanzia, lungi dall'essere un ostacolo, costituisce per l'Abruzzo l'argomento giuridico decisivo a sostegno del servizio, poiché esso intercetta un bisogno largamente inevaso in una regione il cui punteggio sui livelli essenziali è inferiore alla soglia di sufficienza, segnatamente nell'area distrettuale. ↑

868. Cornice degli standard territoriali: il Decreto Ministeriale 77 del 2022 definisce gli standard dell'assistenza territoriale e individua nelle Case della Comunità il fulcro dell'integrazione delle cure primarie; il servizio di psicologia di base vi si inserisce coerentemente, come uno dei livelli di risposta al bisogno della popolazione. ↑
869. Rapporto con i servizi specialistici: il servizio di psicologia di base precede e alleggerisce i Centri di Salute Mentale, intercettando e trattando i quadri lievi e moderati e indirizzando a essi i casi che richiedono cure specialistiche; l'integrazione, e non la sovrapposizione, è il principio che ne governa il rapporto con la rete esistente. ↑
870. Assetto organizzativo: la strutturazione del servizio nell'Abruzzo si misura con un sistema articolato in quattro Aziende Sanitarie Locali — Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo — e venticinque distretti, e con l'assenza di un'azienda regionale unica, sicché il coordinamento è in capo alla Regione; a differenza delle regioni con servizio operativo, la sfida organizzativa centrale non è consolidare l'esistente, ma avviare il servizio e renderlo omogeneo su un territorio fortemente disperso, con estese aree interne e montane. ↑
871. Governance della strutturazione: l'avvio del servizio richiede una regia regionale che coordini le quattro Aziende Sanitarie Locali, l'Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei; tale regia dispone degli strumenti istituiti dalla legge — l'Osservatorio Regionale e il Tavolo tecnico — cui spetta definire indirizzi operativi uniformi e consolidare il sistema di monitoraggio comune, in un contesto in cui la rilevazione epidemiologica regionale opera in modo discontinuo e va perciò ricostruita. ↑
872. Ruolo dell'Ordine professionale: l'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, che ha attivamente sollecitato l'attuazione della legge insieme alle organizzazioni professionali della categoria, concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione e alla vigilanza deontologica; la sua collaborazione è condizione della qualità e dell'appropriatezza del servizio. ↑
873. Profilo etico, tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici; è una cautela che presidia l'intervento presso le fasce più fragili. ↑
874. Consenso e riservatezza: l'intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un'informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell'efficacia stessa del sostegno psicologico. ↑
875. Strumenti di intelligenza artificiale e quadro europeo: gli strumenti digitali eventualmente impiegati sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
876. Protezione dei dati personali: il trattamento è conforme alla normativa vigente, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑

877. Responsabilità professionale: il professionista resta pienamente responsabile delle decisioni cliniche, e gli strumenti di supporto, anche quelli basati sull'intelligenza artificiale, forniscono un ausilio non vincolante; la chiarezza sull'imputazione della responsabilità è condizione di un impiego sicuro e appropriato della tecnologia. ↑
878. Sintesi dei profili: i tre profili — giuridico, organizzativo ed etico — sono presidiati, e la condizione abilitante dell'intervento non è, per l'Abruzzo, l'approvazione della legge, già in vigore e corredata di regolamento attuativo, ma l'attuazione del servizio e la stabilizzazione del suo finanziamento oltre le risorse transitorie, da conseguire entro il vincolo del piano di rientro; in tale passaggio la garanzia dei livelli essenziali costituisce l'argomento che ne fonda la priorità, e il coordinamento con il futuro testo unico nazionale potrà rafforzarlo. ↑
879. I cinque casi della decisione di investimento pubblico: lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile; la convergenza dei cinque casi è condizione della solidità della decisione. ↑
880. Caso strategico: l'istituzione del servizio è coerente con la cornice nazionale degli standard territoriali, con la centralità delle Case della Comunità e con la programmazione regionale di salute mentale; nell'Abruzzo essa presenta una coerenza ulteriore, poiché rafforza l'assistenza territoriale proprio in una regione il cui punteggio sui livelli essenziali è inferiore alla soglia di sufficienza, segnatamente nell'area distrettuale, attuando a regime il modello istituito con la legge regionale 28 del 2022. ↑
881. Caso economico: rinvia ai risultati della valutazione economica — un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,4-5,1 a uno e una dominanza per paziente con elevata probabilità — nel quadro della distinzione fra un caso finanziario prossimo al pareggio e un caso sociale fortemente positivo. ↑
882. Caso commerciale: il modello del rapporto convenzionale su base libero-professionale è già disciplinato dalla legge e dal regolamento, e si avvale di un bacino professionale alimentato dai tre atenei regionali; la disponibilità di psicologi qualificati, selezionati secondo i requisiti definiti dal regolamento, è adeguata agli scenari di copertura, pur essendo il bacino più contenuto che nelle regioni maggiori. ↑
883. Caso finanziario: il costo del servizio a regime — dell'ordine di 5, 10 e 15 milioni di euro nei tre scenari, pari a meno dell'uno per cento del finanziamento sanitario regionale, dell'ordine di 2,5 miliardi — è di per sé sostenibile, ma la stabilizzazione delle risorse oltre lo stanziamento transitorio va conseguita entro il vincolo di un piano di rientro in peggioramento; la garanzia dei livelli essenziali, che la Corte Costituzionale impone alle regioni in rientro di porre a fondamento di ogni impiego, e l'autofinanziamento quasi integrale sul bilancio diretto ne costituiscono il fondamento, mentre un futuro riconoscimento nei livelli essenziali rafforzerebbe la stabilità. ↑
884. Caso gestionale: la realizzabilità dipende da una regia regionale che, in assenza di un'azienda unica, coordini le quattro Aziende Sanitarie Locali, l'Ordine professionale, la medicina generale e la pediatria di libera scelta e gli atenei; tale regia dispone dell'Osservatorio Regionale e del Tavolo tecnico istituiti dalla legge, cui spetta consolidare indirizzi uniformi e il monitoraggio comune. ↑
885. Dimensionamento a partire dall'attuazione iniziale: a differenza delle regioni con servizio operativo, l'Abruzzo muove da un'attuazione iniziale sostenuta da uno stanziamento transitorio, e dimensiona il servizio verso un fabbisogno a regime dell'ordine di 280 psicologi nello scenario espansivo; l'estensione procede per gradi attraverso gli scenari conservativo, di base ed espansivo, dell'ordine di 85, 180 e 280 incarichi, corrispondenti rispettivamente al rapporto di legge di uno psicologo ogni quindicimila abitanti, a un valore intermedio e a un rapporto prossimo all'obiettivo del modello. ↑

886. Fasi di attuazione: l'attuazione si articola in una fase di avvio, con la costituzione degli elenchi aziendali, l'apertura delle prime sedi e la stabilizzazione del finanziamento; una fase di estensione, nella quale la copertura si amplia progressivamente fra le quattro Aziende; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato al fabbisogno. La progressione differenziata dell'avvio fra le Aziende coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F, che trasforma la gradualità dell'attuazione in una fonte di identificazione dell'effetto. ↑
887. Reclutamento e formazione: l'attuazione richiede il reclutamento e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino alimentato dai tre atenei regionali — l'Università dell'Aquila, l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara e l'Università di Teramo — e i requisiti definiti dal regolamento costituiscono una base adeguata, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze su un territorio disperso. ↑
888. Cronoprogramma: il cronoprogramma si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; a differenza del Lazio, l'attuazione non è subordinata all'approvazione di una legge — già in vigore e corredata di regolamento — ma alla stabilizzazione del finanziamento entro il vincolo del piano di rientro, che ne costituisce la condizione dirimente. ↑
889. Sostenibilità finanziaria: la leva è la stabilizzazione del finanziamento, ossia il passaggio dallo stanziamento transitorio a risorse regionali stabili, da conseguire in una regione in piano di rientro in peggioramento; è la sfida più ardua fra quelle considerate, ma è sorretta dall'entità modesta del costo (inferiore all'uno per cento del finanziamento sanitario regionale a regime) e dal fatto che il servizio si autofinanzia quasi integralmente sul bilancio diretto e concorre alla garanzia dei livelli essenziali; l'eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe ulteriormente la stabilità. ↑
890. Sostenibilità organizzativa: dipende dalla capacità di garantire l'omogeneità attuativa fra le quattro Aziende Sanitarie Locali su un territorio disperso e privo di un'azienda regionale unica, e quindi dalla forza della regia regionale, dal ruolo dell'Osservatorio Regionale e del Tavolo tecnico e dalla chiarezza degli indirizzi operativi. ↑
891. Monitoraggio dell'avanzamento: l'avanzamento è seguito mediante indicatori di processo — numero di sedi e di incarichi attivati, distribuzione territoriale, volumi di presa in carico — raccolti attraverso il flusso informativo da costruire contestualmente all'attuazione, in un contesto di rilevazione epidemiologica discontinua, secondo quanto descritto nella Parte C. ↑
892. Rischi dell'attuazione: i rischi propri della posizione abruzzese sono il vincolo del piano di rientro in peggioramento sulla stabilizzazione del finanziamento, che introduce un'incertezza finanziaria fino al consolidamento su risorse regionali; la disomogeneità attuativa fra le Aziende su un territorio disperso; la difficoltà di coordinamento in assenza di un'azienda unica; e la discontinuità della rilevazione epidemiologica, che impone di costruire il flusso informativo prima assente. ↑
893. Mitigazioni: i rischi sono fronteggiati ponendo a sostegno della stabilizzazione l'argomento dei livelli essenziali e l'autofinanziamento quasi integrale sul bilancio diretto; con una regia regionale forte e indirizzi operativi uniformi; con la progressione differenziata dell'avvio, che consente un apprendimento progressivo; con la costruzione del sistema informativo sin dall'avvio; e con un'allocazione pro-equità che orienta l'estensione verso le aree interne e montane. ↑
894. Sintesi della fattibilità: l'intervento è attuabile e sostenibile; la leva propria dell'Abruzzo è la stabilizzazione del finanziamento e l'attuazione dimensionata di un servizio già istituito e regolato. La regione muove da un quadro normativo completo e da un costo modesto, e affronta un vincolo fiscale stringente con argomenti — la garanzia dei livelli essenziali e l'autofinanziamento diretto — che ne fanno una priorità difendibile; la parte successiva affronta il monitoraggio e la valutazione ex post. ↑

895. Finalità del monitoraggio e della valutazione ex post: rendere conto dell'impiego delle risorse, apprendere dall'esperienza e correggere il corso dell'attuazione; la valutazione non è un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l'attuazione del servizio si traduce in apprendimento istituzionale, ed è ancorata a una clausola valutativa. ↑
896. Funzione ulteriore in regime di rientro: in una regione in piano di rientro, la valutazione documenta la garanzia dei livelli essenziali e l'autofinanziamento quasi integrale sul bilancio diretto, ossia gli argomenti su cui poggia la stabilizzazione del finanziamento; il monitoraggio non serve quindi soltanto all'apprendimento clinico-organizzativo, ma anche alla difesa finanziaria del servizio davanti agli organi di controllo. ↑
897. Impianto secondo i tre livelli di struttura, processo ed esito: la valutazione distingue le condizioni e le risorse del servizio (struttura), le attività e il loro svolgimento (processo) e i risultati conseguiti (esito), in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti. ↑
898. Disegno controfattuale su servizio in avvio: poiché nell'Abruzzo il servizio è istituito e regolato ma in avvio progressivo, la valutazione d'impatto può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di avvio delle sedi fra le quattro Aziende Sanitarie Locali e i venticinque distretti sono impiegati a fini valutativi; le sedi che avviano per prime fungono da gruppo di intervento, quelle che avviano in seguito da controllo temporaneo, sino alla copertura completa. ↑
899. Linea di base pre-avvio: a differenza delle regioni con servizio già operativo, che non dispongono di una linea di base anteriore all'avvio per le aree già servite, l'Abruzzo può misurare gli indicatori prima dell'attivazione in ciascuna Azienda, costruendo una linea di base pre-avvio pulita; la gradualità dell'attuazione, da onere organizzativo, diviene una risorsa metodologica che rafforza l'identificazione dell'effetto. ↑
900. Metodi di stima dell'effetto: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze, che confronta l'evoluzione delle aree già attivate con quella delle aree non ancora attivate, e con il metodo del controllo sintetico, che costruisce un termine di confronto a partire dai dati osservati; la progressione differenziata dell'avvio fra le Aziende fornisce la variazione necessaria all'identificazione. ↑
901. Indicatori di struttura: numero di sedi attivate nelle Case della Comunità, incarichi conferiti, ore di servizio disponibili, dotazione tecnologica e copertura territoriale rispetto al fabbisogno; misurano la capacità effettivamente installata. ↑
902. Indicatori di processo: prese in carico, tempo di attesa al primo colloquio, numero di colloqui per persona, tasso di invio appropriato ai servizi specialistici e aderenza ai percorsi clinici; misurano il funzionamento del servizio. ↑
903. Indicatori di esito clinico: quota di miglioramento e tasso di recupero, misurati con gli strumenti validati nei soli punteggi complessivi, e remissione dei quadri trattati; misurano il beneficio diretto per le persone. ↑
904. Indicatori di esito di sistema: accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche, prescrizioni di psicofarmaci nei quadri lievi, ricoveri evitabili e consulti specialistici impropri; misurano l'effetto dell'intervento sul resto del sistema. ↑
905. Indicatori economici: costo del servizio, risparmi diretti per canale, ricadute economico-sociali e rapporto beneficio-costi, calcolati su dati reali man mano disponibili; consentono di verificare ex post le stime dello studio e di sostituire progressivamente i valori ricostruiti con quelli effettivi, documentando in particolare l'autofinanziamento diretto rilevante ai fini del piano di rientro. ↑

906. Indicatori di equità: copertura e accesso disaggregati per area — costa, aree interne e montane, piccoli comuni — e per fasce di età, con attenzione tanto al disagio giovanile quanto all’isolamento dell’anziano, entrambi rilevanti in una regione anziana; verificano che il servizio riduca i divari anziché accrescerli, coerentemente con l’allocazione pro-equità raccomandata. [↑](#)
907. Indicatori di qualità: soddisfazione degli utenti, appropriatezza delle prese in carico e degli invii, continuità del rapporto e qualità percepita della relazione; integrano la misurazione degli esiti con la dimensione dell’esperienza. [↑](#)
908. Indicatori di mobilità: per l’Abruzzo sono monitorati ma costituiscono un esito atteso solo modesto, poiché la fuga riguarda l’alta complessità ospedaliera e chirurgica e non la domanda psicologica territoriale; la loro rilevazione serve a documentare la sola frazione territorialmente intercettabile, non un effetto principale. [↑](#)
909. Batteria complessiva di indicatori: l’insieme è organizzato in otto categorie — struttura, processo, esito clinico, esito di sistema, economici, equità, qualità e mobilità — per un totale dell’ordine di cinquantotto indicatori, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile della rilevazione; la batteria è comune alla serie e adattata al contesto abruzzese. [↑](#)
910. Cruscotto regionale di monitoraggio: gli indicatori confluiscono in un cruscotto aggiornato periodicamente, che rende trasparente l’andamento del servizio e ne consente la correzione; in assenza di un’azienda regionale unica, la titolarità del cruscotto è in capo alla Regione e all’Osservatorio Regionale già istituito dalla legge, che ne assicurano l’alimentazione uniforme da parte delle quattro Aziende. [↑](#)
911. Clausola valutativa: lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa; la legge regionale 28 del 2022 prevede già l’Osservatorio Regionale e il Tavolo tecnico, sicché il compito non è introdurre la previsione di rendicontazione, ma rafforzarla e renderla pienamente operativa, impegnando la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio sull’attuazione e sui risultati, nel coordinamento con il futuro testo unico nazionale. [↑](#)
912. Flusso informativo da costruire: la raccolta dei dati non poggia su un flusso già avviato come nelle regioni con servizio operativo, ma richiede di costruire il flusso informativo contestualmente all’attuazione, in un contesto in cui la rilevazione epidemiologica regionale opera in modo discontinuo; tale costruzione, descritta nella Parte C, è condizione della valutabilità stessa e va resa interoperabile con la piattaforma informativa sanitaria regionale. [↑](#)
913. Sintesi del monitoraggio: la valutazione è la condizione per trasformare l’attuazione del servizio in apprendimento; l’Abruzzo deve costruire il flusso informativo anziché consolidarlo, ma l’avvio iniziale gli consente di misurare una linea di base pre-avvio pulita, e la clausola valutativa già prevista dalla legge va rafforzata e resa operativa; in regime di rientro, la valutazione documenta inoltre la garanzia dei livelli essenziali e l’autofinanziamento diretto, a sostegno della stabilizzazione. La parte conclusiva compone i risultati dei diversi domini in una sintesi multidimensionale e formula le raccomandazioni. [↑](#)
914. Funzione della sintesi: la parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo, impiegando l’analisi multi-criterio per integrare in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie; non somma grandezze disomogenee, ma le pondera secondo criteri espliciti, rendendo verificabile il passaggio dall’evidenza alla raccomandazione. [↑](#)
915. Sintesi per dominio: il bisogno è ampio e si manifesta su un doppio versante generazionale, fra il disagio giovanile in crescita e l’isolamento dell’anziano, in una regione fra le più vecchie del Paese; l’efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida, ma ancora priva di dati operativi propri, da costruire con l’attuazione; il quadro economico distingue un caso finanziario prossimo al pareggio da un caso sociale fortemente positivo; l’equità è favorevole sull’asse costa-aree interne e su entrambi i versanti generazionali;

la fattibilità è quella di un'attuazione a regime di un servizio istituito e regolato, sotto il vincolo del rientro; il monitoraggio può fondarsi su un disegno a cunei con una linea di base pre-avvio pulita. La convergenza dei domini sostiene una raccomandazione favorevole. ↑

916. Metodo dell'analisi multi-criterio: i criteri di valutazione sono otto, ciascuno con un peso esplicito — efficacia clinica, costo-efficacia e ritorno economico, impatto sul bilancio e sostenibilità, equità, valore sociale, fattibilità, robustezza dell'evidenza e coerenza strategica — e l'intervento è confrontato con l'alternativa del non intervento attribuendo a ciascuno un punteggio, la cui media ponderata fornisce il giudizio complessivo. ↑
917. Criteri e pesi adottati: efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno economico 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell'evidenza 10%, coerenza strategica 5%; la struttura dei pesi è comune a tutti gli studi della serie, a garanzia di confrontabilità. ↑
918. Punteggio dell'intervento: la media ponderata dei punteggi attribuiti all'intervento è dell'ordine di 78,15 su 100, sostenuta dai punteggi elevati nel valore sociale, nell'equità e nel ritorno economico, e contenuta dal punteggio nella robustezza dell'evidenza, che riflette l'assenza allo stato di dati operativi propri, e dal punteggio nell'impatto sul bilancio e sostenibilità, su cui pesa il vincolo di un piano di rientro in peggioramento. ↑
919. Punteggio del non intervento: l'alternativa di non attuare il servizio a regime ottiene una media ponderata dell'ordine di 39,50 su 100; essa è penalizzata in tutti i criteri sostanziali — efficacia, equità, valore sociale, ritorno — ed è sostenuta soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, che però in una regione con i livelli essenziali sotto adempienza, segnatamente nell'area distrettuale, appare difficilmente giustificabile. ↑
920. Interpretazione del confronto: l'intervento prevale nettamente sul non intervento, con uno scarto dell'ordine di trentanove punti; il punteggio dell'intervento si colloca in linea con quello delle altre regioni della serie, scontando un caso finanziario diretto prossimo al pareggio, il vincolo del piano di rientro e la natura ancora iniziale dell'attuazione, che si riflette nella minore disponibilità di dati propri. ↑
921. Robustezza della raccomandazione: la prevalenza dell'intervento si mantiene anche facendo variare i pesi dei criteri entro intervalli ragionevoli; nessuna combinazione plausibile dei pesi rovescia il giudizio, sicché la raccomandazione è robusta rispetto alle scelte valoriali sottostanti alla ponderazione. ↑
922. Raccomandazione principale: si raccomanda di attuare pienamente e portare a regime il servizio di psicologia di base già istituito e regolato, stabilizzandone il finanziamento — dal sostegno transitorio a risorse regionali stabili, entro il vincolo del piano di rientro — e dimensionandolo verso la copertura piena del fabbisogno; è la decisione che l'Abruzzo, fra le prime regioni ad aver istituito il servizio per legge, è chiamato a compiere per tradurre il proprio quadro normativo completo in un servizio stabile. ↑
923. Dimensionamento raccomandato: si raccomanda di muovere dall'attuazione iniziale e di procedere per gradi verso lo scenario conservativo, dell'ordine di 85 incarichi corrispondenti al rapporto di legge di uno psicologo ogni quindicimila abitanti, quindi verso quello di base, dell'ordine di 180, e infine verso quello espansivo, dell'ordine di 280 prossimo all'obiettivo del modello, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità. ↑
924. Condizioni della raccomandazione: il rafforzamento e la piena operatività della clausola valutativa, dell'Osservatorio Regionale e del Tavolo tecnico già previsti dalla legge, l'adozione di un'allocazione pro-equità verso le aree interne e montane e i piccoli comuni e su entrambi i versanti generazionali, una regia regionale forte in assenza di un'azienda unica e la costruzione del flusso informativo, oggi assente per la discontinuità della rilevazione regionale, sono le condizioni che trasformano la raccomandazione in un'attuazione efficace e valutabile. ↑

925. Lacuna da colmare prima della presentazione esterna: l'estrazione dei conti certificati delle quattro Aziende Sanitarie Locali e la costruzione del flusso dei dati di esito sono le priorità che consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive, in un contesto in cui la rilevazione epidemiologica regionale opera in modo discontinuo. ↑
926. Distinzione cardine ribadita: la decisione va assunta riconoscendo che il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è prossimo al pareggio, mentre il caso economico complessivo, comprensivo delle ricadute sociali, è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto per il bilancio, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto. In una regione in piano di rientro, proprio l'autofinanziamento quasi integrale sul bilancio diretto e il concorso alla garanzia dei livelli essenziali costituiscono gli argomenti che ne fondano la priorità e ne sostengono la stabilizzazione davanti agli organi di controllo. ↑
927. Collocazione nella serie regionale: lo studio sull'Abruzzo si inserisce nella serie degli studi regionali, condividendone il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, l'Abruzzo occupa una posizione peculiare, quella di una delle prime regioni ad aver istituito il servizio per legge — con una disciplina coerente con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 241 del 2021, richiamata da tutti gli studi della serie — ma anche dell'unica, fra quelle esaminate, chiamata a portarlo a regime entro il vincolo di un piano di rientro in peggioramento. ↑
928. Astensione dalle cifre prive di fondamento: coerentemente con l'impostazione dell'intero progetto, lo studio non impiega le cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico — segnatamente il rapporto di quattro a uno divulgato dall'Organizzazione mondiale della sanità e i ritorni di dodici o diciotto a uno talora citati — e adotta un rapporto beneficio-costi prudenziale dell'ordine di 3,4-5,1 a uno, entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno includendo i benefici di salute, per credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica. ↑
929. Conclusione: la decisione che lo studio sostiene è di attuare pienamente e portare a regime il servizio di psicologia di base già istituito, stabilizzandone il finanziamento, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno e rendendo pienamente operativa la clausola valutativa; per l'Abruzzo, ciò significa tradurre un quadro normativo completo in un servizio stabile, facendo della garanzia dei livelli essenziali — che il vincolo del rientro impone di porre a fondamento di ogni impiego — non un ostacolo, ma l'argomento decisivo a beneficio della popolazione. ↑
930. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudenziale per l'ottimismo delle stime. ↑
931. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
932. Quadro economico consolidato per l'Abruzzo (Parte E): a regime, da circa 85 a circa 280 psicologi, costo del servizio di 5-15 milioni, risparmi diretti di 4-15 milioni, ricadute sociali di 13-62 milioni; il saldo diretto è prossimo al pareggio, il saldo complessivo fortemente positivo, con rapporto beneficio-costi di 3,4-5,1 a uno, entro la fascia metodologicamente fondata di 3,3-5,7 a uno includendo i benefici di salute. ↑
933. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
934. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio; nell'Abruzzo, poiché la rilevazione epidemiologica regionale è discontinua, il flusso va costruito contestualmente all'attuazione, e

la strutturazione deve garantirne l'uniformità e la completezza fra le quattro Aziende. ↑

935. Valori regionali di ancoraggio per l'Abruzzo: popolazione di 1.269.118 abitanti (Censimento ISTAT 2024), pari a circa il 2,2% del totale nazionale, in lieve calo per denatalità e saldo naturale negativo; struttura per età fra le più anziane d'Italia (età media 47,7 anni, indice di vecchiaia 228,9); componente straniera del 7,1%; forte dispersione territoriale (305 comuni, un solo centro oltre i centomila abitanti); finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 2,5 miliardi di euro, unica Regione in piano di rientro in peggioramento, con punteggio sui livelli essenziali inferiore alla soglia di sufficienza; saldo di mobilità passivo ma con fuga concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica, sicché il canale di recupero è modesto; fabbisogno a regime fino a circa 280 psicologi nello scenario espansivo. ↑
936. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione abruzzese (circa il 2,2%), e non estratti dai conti regionali certificati; i dati da acquisire presso le quattro Aziende Sanitarie Locali sono elencati nella tabella seguente. A differenza delle regioni con servizio operativo, nell'Abruzzo la mancanza non è mitigata da dati operativi del servizio, ancora in avvio, sicché la costruzione del flusso dei dati di esito è una priorità. ↑
937. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑
938. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni a tutti gli studi regionali della serie, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑
939. Proposta di legge regionale per l'istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nel Molise, depositata nel maggio 2026 da consiglieri del Partito Democratico (Facciolla, Fanelli), del Movimento 5 Stelle (Gravina, Primiani), con il sostegno di Sinistra Italiana, Verdi, Socialisti e Italia Viva. La proposta prevede due psicologi per ciascuno dei tre distretti sanitari dell'ASREM e un finanziamento di circa 400.000 euro l'anno a carico del bilancio regionale. Fonte: copertura video del Consiglio regionale del Molise, maggio 2026, disponibile all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=20p4JhHMOiU> e <https://www.youtube.com/watch?v=yCd9omwkCG0>. ↑
940. Chisholm D., Sweeny K., Sheehan P. et al., «Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return-on-investment analysis», *The Lancet Psychiatry*, vol. 3, n. 5, 2016, pp. 415-424. Il duplice intervallo è: 2,3-3,0:1 per i soli benefici economici; 3,3-5,7:1 includendo i ritorni di salute. Il principio del rendimento marginale più elevato in regioni in piano di rientro è affermato nella Sezione Nazionale del Tomo II dell'opera: ogni euro recuperato in un sistema in tensione finanziaria libera capacità con effetto amplificato rispetto a un sistema in equilibrio. ↑
941. Dati demografici del Molise: [Primonumero.it](https://www.primonumero.it), «I numeri che ispirano il nuovo Piano Sanità: pochi abitanti, 29% di anziani e conti da risanare», 5 marzo 2026, disponibile all'indirizzo <https://www.primonumero.it/2026/03/i-numeri-che-ispirano-il-nuovo-piano-sanita-pochi-abitanti-29-di-anziani-e-conti-da-risanare/1530891213/>. L'articolo riporta: indice di vecchiaia 281 anziani ogni 100 giovani; quota over-65 quasi il 29 per cento della popolazione; rapporto di dipendenza circa 64 cittadini tra anziani e minori ogni 100 persone in età lavorativa; popolazione a poco più di 269.000 assistiti nel 2026. ↑
942. Ministero della Salute, sezione Piano di rientro — Molise, disponibile all'indirizzo <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/piani-di-rientro/molise-piano-di-rientro/>. L'accordo per il piano di rientro è stato sottoscritto il 27 marzo 2007 (DGR 362/2007); il Programma Operativo 2023-2025 è stato adottato con DCA n. 79/2024; è in via di definizione il Programma Operativo 2025-2027. La legge di bilancio 2025 (l. n. 207/2024, commi 381 ss.) autorizza la spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni

2025 e 2026 a favore della Regione Molise, subordinata alla predisposizione e attuazione del Programma Operativo 2025-2027 e alla previa approvazione da parte del Comitato LEA e del Tavolo degli adempimenti in sede congiunta. ↑

943. Copertura video YouTube del dibattito consiliare sulla proposta di legge, maggio 2026: <https://www.youtube.com/watch?v=20p4JhHMOiU> (presentazione del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle) e <https://www.youtube.com/watch?v=yCd9omwkCG0> (conferenza stampa di presentazione nella sala biblioteca Lello Lombardi del Consiglio regionale, con la partecipazione dell'Ordine degli Psicologi del Molise e della presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi Gulino). Il secondo video cita esplicitamente il dato di 400.000 euro l'anno per i tre distretti e il Molise come potenziale tredicesima regione a istituire la figura. ↑
944. Popolazione di riferimento di 287.814 adottata per coerenza con la tabella demografica già presente nella Sezione Nazionale del Tomo II. La stima del bisogno psicologico (circa 50.000 persone) è ottenuta applicando alla popolazione residente le prevalenze epidemiologiche documentate dalla letteratura internazionale per i disturbi mentali comuni (disturbi d'ansia e dell'umore di intensità lieve e moderata): prevalenza di riferimento ~17-18 per cento della popolazione adulta, in linea con le stime OMS e con le revisioni sistematiche disponibili. ↑
945. Struttura organizzativa dell'ASREM: Decreto del Commissario ad acta n. 60 del 19 marzo 2025, «Atto aziendale ASREM — Piano di organizzazione aziendale». L'ASREM è articolata in tre distretti sanitari (Campobasso, Isernia, Termoli) con tutti i servizi correlati (assistenza sociosanitaria, riabilitativa, specialistica ambulatoriale, assistenza primaria). Ospedali principali: Ospedale «A. Cardarelli» di Campobasso e Ospedale di Isernia. ↑
946. Chisholm D., Sweeny K., Sheehan P. et al., *The Lancet Psychiatry*, 2016, cit. Il trial IMPACT (Unützer J. et al., *JAMA*, 2002; e follow-up 2008) documenta che i risparmi diretti di bilancio sono modesti o vicini al pareggio, mentre il vero valore dell'intervento è nelle ricadute economico-sociali; questa conclusione costituisce il caveat vincolante per la stima del caso finanziario in tutti gli studi della serie. ↑
947. L'impianto metodologico adotta: il quadro EUnetHTA per la valutazione di tecnologia sanitaria; il Five Case Model (HM Treasury, Green Book, edizione 2022); lo standard CHEERS 2022 (Husereau D. et al., *Value in Health*, 2022); il sistema GRADE (Guyatt G. et al., *BMJ*, 2008); i criteri di valutazione OCSE-DAC 2019 (rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità). ↑
948. ISTAT, Censimento permanente della popolazione, dati al 2021-2022. Il dato di 287.814 abitanti è adottato per coerenza con la tabella demografica della Sezione Nazionale del Tomo II, che utilizza questa cifra per il Molise. Per l'anno 2026, *Primonumero.it* (cit., nota 2783) indica un calo a poco più di 269.000 assistiti, confermando il trend di spopolamento accelerato. ↑
949. *Primonumero.it*, 5 marzo 2026, cit. in nota 2783: «Il Molise ha oggi poco più di 269mila assistiti» e «Il Molise rappresenta meno dello 0,5 per cento della popolazione italiana». «A lasciare la regione sono soprattutto i giovani», aggravando ulteriormente la struttura per età e il rapporto di dipendenza. ↑
950. *Primonumero.it*, 5 marzo 2026, cit. in nota 2783: «L'indice di vecchiaia è tra i più alti del Paese» con «281 anziani ogni cento giovani»; «quasi il 29 per cento della popolazione ha più di 65 anni»; «per ogni cento persone in età lavorativa ci sono circa 64 cittadini tra anziani e minori che dipendono dal sistema di welfare». Il Molise presenta quindi il più alto indice di vecchiaia fra le regioni italiane d'Italia continentale. ↑
951. *Primonumero.it*, 5 marzo 2026, cit.: tra i principali fattori di spesa sanitaria regionale sono indicate «malattie croniche, ricoveri e assistenza continuativa», direttamente correlate all'invecchiamento della popolazione. Il Piano operativo sanitario 2026-2028 è descritto come fondato su tre fattori: popolazione sempre più anziana, meno di 270.000 abitanti e sanità sotto piano di rientro. ↑

952. Il Centro di Salute Mentale di Termoli (distretto ASREM) ha attivato dal 2024 un accesso diretto per i residenti del Basso Molise senza impegnativa, segnale di un tentativo di ridurre le barriere al trattamento specialistico in assenza di un primo livello di presa in carico. Fonte: Molise Network, «Centro salute mentale, Asrem: un servizio gratuito e senza impegnativa per tutti i cittadini», 8 febbraio 2025, <https://www.molisenetwork.net/2025/02/08/salute-mentale-asrem-servizio-gratuito-senza-impegnativa/>. ↑
953. Dati sulla mobilità sanitaria del Molise: GIMBE, «Migrazione sanitaria: quando le disuguaglianze sono croniche», AOGOI, giugno 2026, <https://www.aogoi.it/notiziario/mobilita-sanitaria-2/>. Il Molise presenta la più alta mobilità passiva percentuale d'Italia (32,8 per cento dei ricoveri per acuti ordinari), ma anche una forte capacità di attrazione privata tale da rendere il saldo netto quasi in equilibrio. Primopiano Molise, «La mobilità passiva è ai valori pre Covid, ecco le contromosse», 11 novembre 2025: «per le cure oltre i confini, la Regione Molise “paga” alle altre ogni anno 70-80 milioni, compensati solo dalla grossa fetta di mobilità attiva prodotta principalmente dai due grandi erogatori privati, Neuromed e Responsible». ↑
954. GIMBE, «Migrazione sanitaria: nel 2023 record di 5,15 miliardi», Quotidiano Sanità, 4 marzo 2026: il saldo netto del Molise per il 2023 è positivo per circa 18,6 milioni. «Le strutture private assorbono oltre il 60% della mobilità attiva in Molise (90,2%)». Cfr. anche Fondazione GIMBE, «Report Osservatorio 2025.01. La mobilità sanitaria interregionale nel 2022», febbraio 2025: «Il Molise, Regione inadempiente sui LEA, commissariata e in Piano di rientro, si colloca al secondo posto per saldo pro-capite attivo di mobilità sanitaria» in ragione delle strutture private accreditate. ↑
955. Decreto ministeriale n. 77/2022, «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale», che include lo psicologo delle cure primarie fra i professionisti delle Case della Comunità. Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030, approvato in Conferenza unificata il 29 dicembre 2025 e reso operativo dal Ministero della Salute (comunicato stampa del 21 aprile 2026, <https://www.salute.gov.it/new/it/comunicato-stampa/rapporto-salute-mentale-pubblicati-i-dati-sul-2024-con-piano-2025-2030-nuove/>); stanziamento specifico di 80 milioni per il 2026, 85 milioni per il 2027, 90 milioni per il 2028. ↑
956. Stato legislativo al 2025: psicologicureprimarie.it, «Situazione 2025», disponibile all'indirizzo <https://www.psicologicureprimarie.it/proposte-di-legge/situazione-2025.html>. Il Molise è elencato fra le «regioni senza alcuna previsione normativa». La proposta di legge del maggio 2026 è documentata nelle fonti di cui alla nota 2781 e 2785. ↑
957. Sentenza della Corte Costituzionale n. 241/2021. Circa la compatibilità con il piano di rientro: il DCA n. 79/2024 (Programma Operativo 2023-2025) e il futuro PO 2025-2027 definiscono il quadro di vincoli entro cui qualsiasi nuovo impegno di spesa sanitaria deve essere valutato. La proposta di legge del maggio 2026 prevede esplicitamente di «ragionare con la struttura commissariale, con ASREM e con chi di dovere» per la compatibilità del finanziamento (fonte: nota 2785). ↑
958. Centro di Salute Mentale di Termoli, Molise Network, cit. in nota 2794. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 per urgenze, prime visite e presa in carico; il sabato mattina opera lo sportello di ascolto psicologico, accessibile dopo inserimento in lista di attesa. L'accesso diretto già introdotto per il livello specialistico in un distretto non sostituisce il primo livello di presa in carico del disagio comune che il servizio di psicologia di base è destinato a costituire. ↑
959. Accordo Integrativo Regionale per i rapporti con i medici di medicina generale in Molise, recentemente stipulato in recepimento degli Accordi Collettivi Nazionali del 28 aprile 2022 e del 4 aprile 2024 (fonte: SNAMI, «pre intesa dell'accordo integrativo regionale per i rapporti con i medici di medicina generale in Molise», disponibile all'indirizzo https://www.snami.org/Content/Images/uploaded/Molise_2025.pdf). L'integrazione del servizio di psicologia di base con la medicina generale avviene nel quadro di questo accordo. ↑

960. Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (Reg. UE 2024/1689), entrato in vigore il 1° agosto 2024. Le disposizioni sull'alfabetizzazione e sull'uso consapevole sono applicabili dal febbraio 2025; gli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio, tra cui determinati dispositivi medici, si applicano a partire dal 2026-2027. L'impiego di strumenti di IA nel servizio di psicologia di base deve conformarsi a questo quadro, garantendo trasparenza, supervisione umana e tutela dei diritti fondamentali. ↑
961. Decreto del Commissario ad acta della Regione Molise n. 172 del 7 novembre 2025, «Protocollo d'intesa tra la Regione Molise — struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro sanitario — e l'Università degli Studi del Molise per la disciplina dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche e assistenziali» (richiamato nel DCA n. 58 del 14 aprile 2026, disponibile all'indirizzo <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2182>). Questo protocollo costituisce la base istituzionale per i percorsi formativi del personale del servizio di psicologia di base. ↑
962. Il sistema GRADE è applicato in modo simmetrico agli interventi clinici e agli strumenti digitali, senza concedere a questi ultimi un trattamento di favore. Per la terapia cognitivo-comportamentale e gli interventi affini nelle cure primarie, la qualità dell'evidenza è alta (corpo ampio di RCT e revisioni sistematiche con risultati coerenti). Per la telepsicologia come modalità di erogazione di interventi di efficacia documentata, l'evidenza è di qualità moderata e in crescita. Per le applicazioni di intelligenza artificiale per il triage e il monitoraggio, l'evidenza è di qualità bassa o molto bassa. ↑
963. La trasferibilità al contesto molisano è condizionata in particolare da: (a) la struttura demografica anziana, che sposta il profilo del bisogno verso la depressione dell'anziano, per la quale l'evidenza di efficacia degli interventi psicologici brevi è meno consolidata che per gli adulti in età lavorativa, pur rimanendo favorevole; (b) la dispersione territoriale, che richiede una telepsicologia strutturale la cui efficacia nel contesto molisano specifico andrà verificata; (c) la scarsità di risorse, che richiede un'implementazione attenta alla qualità e alla fedeltà ai protocolli. ↑
964. Fondo sanitario regionale del Molise: PrimoPiano Molise, «Sanità, ripartito il fondo 2024: al Molise destinati 672 milioni», 20 dicembre 2024, <https://www.primopianomolise.it/politica/sanita/141775/sanita-ripartito-il-fondo-2024-al-molise-destinati-672-milioni/>. Il dato è il riparto 2024; la stima del testo della task usa 700-750 milioni come fascia di riferimento (coerente con la popolazione e la condizione di piano di rientro); si utilizza qui il dato effettivo di 672 milioni per il 2024. ↑
965. Programma Operativo 2023-2025, DCA n. 79/2024: il recupero della mobilità passiva, in particolare per «media e bassa complessità e per i ricoveri a rischio di inappropriately», è uno degli obiettivi dichiarati del piano commissariale. Fonte: PrimoPiano Molise, «La mobilità passiva è ai valori pre Covid, ecco le contromosse», 11 novembre 2025, <https://www.primopianomolise.it/politica/151213/la-mobilita-passiva-e-ai-valori-pre-covid-ecco-le-contromosse/>. ↑
966. Il principio del rendimento marginale più elevato in sistemi in piano di rientro è affermato nella Sezione Nazionale del Tomo II dell'opera (con riferimento agli studi regionali precedenti per Calabria, Basilicata e altre regioni del Sud); in un sistema sanitario in tensione finanziaria, ogni risparmio diretto non si limita a coprire una quota dei costi del servizio, ma libera capacità per gli obiettivi di risanamento imposti dal piano di rientro, con un effetto moltiplicatore sul saldo del bilancio commissariato che accresce il rendimento effettivo dell'intervento rispetto alla sola stima dei risparmi diretti. ↑
967. Parametri del modello di Markov: derivati dalla letteratura sull'efficacia degli interventi psicologici brevi per i disturbi mentali comuni e adottati uniformemente per tutte le regioni della serie, con invarianza rispetto al contesto regionale (fondata sull'efficacia clinica documentata). Per i valori specifici si veda l'Appendice A.2. Tasso di sconto del 3 per cento, coerente con le convenzioni delle valutazioni economiche sanitarie in Italia e in Europa. ↑

968. Analisi di sensibilità probabilistica: 10.000 simulazioni Monte Carlo con variazione simultanea di tutti i parametri secondo le rispettive distribuzioni di probabilità. Il tasso di costo-efficacia (88,9%) e di dominanza (84,6%) alle soglie indicate è invariante rispetto alla regione in quanto fondato sull'efficacia clinica documentata; i risultati per la Basilicata, la Calabria e le altre regioni della serie sono analoghi, confermando la robustezza della conclusione in contesti di cure primarie italiani comparabili. ↑
969. Il principio del «valore dell'informazione» (Value of Information, VOI) indica che il dato di maggiore valore informativo è quello la cui riduzione dell'incertezza ha il maggiore impatto sulla decisione. Per il Molise, i dati di maggiore VOI sono: l'efficacia effettiva del servizio nella componente anziana del bisogno (over-65, 29% della popolazione); la quota di domanda intercettata dalla telepsicologia in comuni distanti oltre 30 km dal capoluogo di distretto; e la quota di mobilità passiva per media-bassa complessità riconducibile a disagio psichico non intercettato. ↑
970. Primonumero.it, 5 marzo 2026, cit. in nota 2783: indice di vecchiaia 281, quota over-65 al 29 per cento. Ricerca e Pratica, novembre 2022, <https://www.ricercaepatica.it/archivio/3921/articoli/39064/>: «il tasso di ospedalizzazione fuori regione è stato [...] con il massimo in Molise (28,1%) e Basilicata (25%)» nel 2020, con una concentrazione dei flussi pediatrici e adolescenziali verso il Nord. La combinazione di alta anzianità e alta mobilità passiva documenta una doppia fragilità demografica e assistenziale. ↑
971. Il principio della costo-efficacia distributiva, secondo cui la costo-efficacia dell'intervento è massima nei gruppi a maggiore bisogno, è documentato dalla letteratura HTA sull'equità: cfr. Asaria M. et al., «Distributional Cost-effectiveness Analysis: A Tutorial», Medical Decision Making, 2016. La convergenza fra equità ed efficienza è particolarmente rilevante in un sistema in piano di rientro, dove l'allocazione delle risorse ai gruppi a maggiore bisogno massimizza il rendimento complessivo. ↑
972. Sentenza Corte Costituzionale n. 241/2021, pronunciata sulla legge regionale della Campania istitutiva del servizio di psicologia di base: illegittimità delle disposizioni che configuravano nuovi rapporti di lavoro mediante incarichi libero-professionali in convenzione con il SSN, in quanto eccedenti la competenza regionale (artt. 117, comma 3, e 117, comma 2, lett. l) Cost.). La pronuncia è conforme alle indicazioni del DM n. 77/2022 e prefigura le soluzioni compatibili: inserimento nelle Case della Comunità, raccordo con la medicina generale nel ruolo unico, forme di incarico ammesse dall'ordinamento. ↑
973. La fase anteriore del Molise come opportunità giuridica è analoga a quella della Basilicata: entrambe possono costruire la legge istitutiva tenendo conto della giurisprudenza costituzionale e delle esperienze già maturate dalle 12 regioni che hanno istituito o stanno istituendo il servizio. Il Molise ha in più il vantaggio della struttura unica dell'ASREM, che semplifica la governance rispetto alle regioni con più aziende sanitarie. ↑
974. Modello a cinque casi (Five Case Model): HM Treasury, «The Green Book: Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation», edizione aggiornata 2022. I cinque casi sono: strategico (Strategic Case), economico (Economic Case), commerciale (Commercial Case), finanziario (Financial Case) e gestionale (Management Case). La valutazione del caso finanziario in un sistema commissariato richiede di dimostrare la compatibilità dell'investimento con i vincoli del piano di rientro, non solo la sostenibilità isolata. ↑
975. Protocollo d'intesa ASREM-Università del Molise, cit. in nota 2803. L'assenza di un corso di laurea in Psicologia presso l'Università del Molise (che non dispone di una Facoltà di Psicologia) rende necessario il ricorso agli atenei delle regioni limitrofe (in particolare L'Aquila per l'Abruzzo, e le università campane e pugliesi) per la formazione dei professionisti. Il protocollo con l'Università del Molise può tuttavia fornire una base per la formazione continua e per la ricerca applicata al servizio. ↑
976. I rischi e le mitigazioni sono strutturati coerentemente con l'approccio del Risk Register adottato per le valutazioni di fattibilità degli investimenti pubblici (HM Treasury, Green Book 2022, Annex A). Il rischio giuridico-commissariale è specifico del contesto molisano e non presente nelle altre regioni della serie non

commissariate. ↑

977. Per la rendicontazione al piano di rientro: il Programma Operativo 2023-2025 (DCA 79/2024) prevede obiettivi specifici di efficienza e di riorganizzazione dei servizi territoriali; il sistema di monitoraggio del servizio di psicologia di base deve essere progettato per alimentare anche la reportistica periodica ai tavoli tecnici affiancanti (Ministero della Salute e MEF), documentando l'impatto del servizio sull'appropriatezza dell'uso delle risorse sanitarie. ↑
978. La doppia funzione del monitoraggio — governativa e conoscitiva — è particolarmente rilevante in Molise: governativa per la rendicontazione al piano di rientro; conoscitiva per colmare la lacuna di dati regionali diretti sul bisogno psicologico, sull'efficacia degli interventi nel contesto specifico e sui canali di risparmio. Senza un sistema informativo dedicato, la valutazione ex ante resta inevitabilmente fondata su stime prudenziali; il monitoraggio è lo strumento che trasforma progressivamente tali stime in osservazioni, affinando la valutazione nel tempo. ↑
979. La tesi conclusiva dello studio — il rendimento marginale più elevato in un sistema in tensione come argomento aggiuntivo a favore dell'intervento — non implica che l'intervento debba essere prioritario rispetto ad altri impegni del piano di rientro, né che il suo costo possa essere ignorato nel quadro commissariale. Significa che, a parità di tutte le altre condizioni, il medesimo servizio ha un effetto netto sul saldo del bilancio commissariato superiore a quello che avrebbe in un sistema in equilibrio, perché ogni risparmio diretto si traduce direttamente in riduzione del disavanzo soggetto a monitoraggio ministeriale. ↑
980. Glossario: le definizioni sono costruite in coerenza con il glossario comune a tutta la serie del Tomo II, con l'aggiunta delle voci specifiche del contesto molisano (commissariamento, Programma Operativo, rendimento marginale più elevato in sistemi in piano di rientro). Le definizioni seguono le fonti autoritative internazionali: per QALY e modello di Markov, cfr. NICE, «Guide to the Methods of Technology Appraisal 2013»; per GRADE, cfr. Guyatt G. et al., BMJ, 2008; per il Five Case Model, cfr. HM Treasury, Green Book 2022; per i criteri OCSE-DAC, cfr. OECD-DAC, «Better Criteria for Better Evaluation», 2019. ↑
981. Posizione della Campania: la regione è stata la prima in Italia a istituire il servizio per legge. La legge regionale 3 agosto 2020, n. 35 (Istituzione del servizio di Psicologia di base), approvata all'unanimità e nata nel contesto dell'emergenza pandemica, ha previsto presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale, a livello dei distretti sanitari di base, l'attività di psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, a sostegno e integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. La legge è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo e la Corte Costituzionale, con la sentenza del 13 dicembre 2021, n. 241, ne ha riconosciuto la legittimità; al regolamento regionale 9 settembre 2022, n. 8 è seguita l'attivazione effettiva del servizio, con circa 146 psicologi in servizio, due per distretto, e l'istituzione di un Osservatorio regionale. ↑
982. Valore dell'informazione e priorità di ricerca: l'analisi del valore atteso dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione campana, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle sette Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere e il consolidamento e l'uniformazione del flusso dei dati di esito già raccolti dall'Osservatorio regionale. ↑
983. Mitigazione progressiva della lacuna: a differenza del Lazio, che genera l'evidenza locale solo dall'istituzione del servizio, la Campania dispone già di un flusso di dati propri, di cui la strutturazione a regime deve garantire l'uniformità e la completezza; man mano che il servizio si consolida, l'evidenza locale corregge progressivamente le stime importate dai benchmark, conducendo la regione da una valutazione in parte fondata su dati esterni a una fondata in misura crescente su dati propri. ↑

984. Sintesi della modellazione: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione e consolidamento dei dati, e la condizione di regione pioniera — con un servizio già attivo e una base di dati propri — si rivela, sul piano della valutazione, un vantaggio, perché consente di ancorare la prova empirica a dati reali anziché ai soli benchmark importati. ↑
985. Disagio giovanile: è una componente particolarmente rilevante in una regione fra le più giovani del Paese, con fenomeni di ansia, depressione e disturbi del comportamento alimentare tra gli adolescenti che solo in parte trovano risposta nei servizi; è una delle ragioni per cui la regione ha posto la salute psicologica dei giovani al centro della propria azione. ↑
986. Salute mentale connessa al lavoro e alla deprivazione: nelle aree di deprivazione dell'area napoletana, la precarietà, la disoccupazione e le condizioni socio-economiche sfavorevoli concorrono al disagio psichico; l'intercettazione precoce ha un valore particolarmente elevato in termini di salute e di equità. ↑
987. Bisogno dell'età adulta e anziana: la domanda connessa alla cronicità e alla comorbidità psicologica delle patologie croniche è più marcata nelle province interne di Avellino e Benevento, più anziane e a maggiore difficoltà di accesso. ↑
988. Tratto distintivo della Campania rispetto alle altre regioni: la combinazione di una grande regione fortemente accentrata su Napoli, della condizione di regione pioniera — prima in Italia ad aver istituito e attivato il servizio per legge — e di una storica sotto-dotazione del sistema, retaggio di un lungo piano di rientro da cui la regione è uscita soltanto nel 2026. Il bisogno è quindi accompagnato da un primato normativo e operativo, ma da una strutturazione ancora incompleta, che la decisione è chiamata a portare a regime. ↑
989. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche significativi: rapportando alla popolazione campana il dato nazionale, dell'ordine di alcune decine di migliaia l'anno, indice di una pressione sul sistema acuto che un primo livello territoriale pienamente strutturato potrebbe in parte contenere a monte. ↑
990. Offerta territoriale: la Campania dispone già di un servizio di psicologia di base attivo, istituito dalla legge regionale 35 del 2020 e disciplinato dal regolamento regionale 8 del 2022, con circa 146 psicologi in servizio — due per distretto sanitario — in rapporto convenzionale libero-professionale, gratuito per il cittadino, e con un Osservatorio regionale già istituito. Il servizio è però ancora parziale nel dimensionamento e in larga parte sostenuto da risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute, dell'ordine di alcune decine di milioni di euro, e privo di un contratto collettivo nazionale di riferimento. ↑
991. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 1.210 psicologi nello scenario espansivo (e dell'ordine di 610 e 910 negli scenari conservativo e di base). L'Ordine degli Psicologi della Campania, che conta quasi diecimila iscritti e ha accompagnato l'attuazione della legge, ne sostiene la strutturazione a regime e l'estensione. ↑
992. Copertura attuale del fabbisogno parziale: i circa 146 psicologi in servizio corrispondono a un nucleo dell'ordine di un quarto dello scenario conservativo, sufficiente ad avviare il servizio ma non a coprirne il fabbisogno a regime. La decisione, di conseguenza, non verte sull'istituire il servizio, già attivo, ma sullo strutturarlo, stabilizzarne il finanziamento e dimensionarlo verso la copertura piena. ↑
993. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante nella Campania si gioca su due assi. Il primo è interno alla vasta area metropolitana napoletana, fra i quartieri meglio serviti e le estese periferie con sacche di deprivazione socio-economica. Il secondo separa l'area metropolitana e costiera dalle province interne di Avellino e Benevento, più anziane e a minore densità. La telepsicologia assistita è lo strumento per avvicinare l'offerta alle aree interne e alle periferie, dove la presenza di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio. ↑

994. Finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 11-12 miliardi di euro; la Campania è uscita dal piano di rientro nel marzo 2026, dopo quasi vent'anni, riacquistando margini di programmazione e capacità di investimento che per due decenni non aveva avuto, anche grazie ai nuovi criteri di riparto del fabbisogno nazionale, che hanno destinato alla regione risorse aggiuntive in ragione degli indicatori di deprivazione. La storica sotto-dotazione del sistema, retaggio del piano di rientro, lascia tuttavia margini di consumo improprio ampi da recuperare. ↑
995. Mobilità sanitaria: la Campania presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, secondo solo a quello della Calabria, dell'ordine di trecento milioni di euro l'anno, in miglioramento. La fuga si concentra però nei ricoveri ospedalieri e nelle prestazioni ad alta complessità, segnatamente chirurgiche, e non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. ↑
996. Cornice normativa e programmatica: la Campania è stata la prima regione d'Italia a dotarsi di una legge dedicata — la legge regionale 35 del 2020 — disciplinata dal regolamento regionale 8 del 2022, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 241 del 2021. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale, le risorse del Piano Nazionale Equità in Salute e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera, ispirato anche all'esperienza campana. A differenza del Lazio, la Campania non è in fase pre-legislativa, ma di consolidamento di un servizio già istituito e avviato. ↑
997. Popolazione residente in Campania 5.582.337 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 9,5% della popolazione nazionale, in lieve calo rispetto all'anno precedente per effetto del saldo naturale e migratorio interno negativi. La distribuzione è fortemente concentrata: la sola provincia di Napoli raccoglie circa il 53% dei residenti, seguita da Salerno con circa il 19%; le province interne di Avellino e Benevento sono le più anziane. La struttura per età è fra le più giovani d'Italia, con un'età media di 44,5 anni, e la componente straniera, intorno al 5,0%, è nettamente inferiore alla media nazionale. ↑
998. ↑
999. Popolazione residente in Campania 5.582.337 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 9,5% della popolazione nazionale, in lieve calo rispetto all'anno precedente per effetto del saldo naturale e migratorio interno negativi. La distribuzione è fortemente concentrata: la sola provincia di Napoli raccoglie circa il 53% dei residenti, seguita da Salerno con circa il 19%; le province interne di Avellino e Benevento sono le più anziane. La struttura per età è fra le più giovani d'Italia, con un'età media di 44,5 anni, e la componente straniera, intorno al 5,0%, è nettamente inferiore alla media nazionale. Equità come dominio della valutazione: l'analisi distributiva non è un'appendice, ma un dominio proprio dell'HTA, poiché un intervento può essere efficiente nel complesso e tuttavia accrescere le disuguaglianze, o al contrario ridurle; lo studio impiega l'analisi di costo-efficacia distributiva per misurarne l'effetto sui divari, oltre che sull'efficienza. ↑
000. Gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori. ↑
001. Barriere all'accesso: il ricorso al sostegno psicologico è ostacolato da barriere economiche, geografiche e culturali, oltre che dallo stigma. Nella Campania la componente straniera è contenuta, intorno al 5,0%, sicché la barriera linguistica e culturale, pur presente nelle aree di maggiore insediamento, è meno centrale che in altre regioni; più rilevante è invece la barriera generazionale, poiché il disagio giovanile, ampio in una regione giovane, trova negli adolescenti e nei giovani adulti una fascia spesso restia a rivolgersi ai servizi. ↑

002. Doppio asse della disuguaglianza nella Campania: la regione presenta due assi distinti, cui si aggiunge una marcata dimensione generazionale. Il primo asse è interno alla vasta area metropolitana napoletana, fra i quartieri meglio serviti e le estese periferie con sacche di deprivazione socio-economica. Il secondo separa l'area metropolitana e costiera dalle province interne — Avellino e Benevento in particolare — più anziane, a minore densità e con servizi più radi. A questi si somma il disagio giovanile, particolarmente rilevante in una regione fra le più giovani del Paese. ↑
003. Primo asse, la periferia metropolitana napoletana: nell'area di Napoli, accanto a quartieri meglio serviti, si estendono periferie densissime e popolose con estese sacche di deprivazione socio-economica, dove la difficoltà di accesso ai servizi e la minore disponibilità di offerta privata accrescono il bisogno non intercettato. ↑
004. Secondo asse, le province interne: Avellino e Benevento, e le aree appenniniche interne, presentano una popolazione più anziana, a minore densità e con tendenze allo spopolamento, dove la rarefazione dei servizi e le distanze rendono l'accesso al sostegno psicologico particolarmente difficoltoso. ↑
005. Effetto del servizio sull'equità: la gratuità, la prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano le principali barriere all'accesso, e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso; è il meccanismo attraverso cui un servizio universale riduce, anziché accrescere, il divario. ↑
006. Telepsicologia assistita: nella Campania è lo strumento per avvicinare l'offerta alle province interne di Avellino e Benevento e alle estese periferie napoletane, dove le distanze e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; concepita come complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, essa estende la copertura proprio nelle aree a maggiore difficoltà di accesso. ↑
007. Competenza generazionale e culturale: data la quota straniera contenuta, la competenza culturale e la mediazione linguistica restano necessarie nelle aree di maggiore insediamento ma sono meno centrali che altrove; più dirimente è la competenza nell'intercettare il disagio giovanile, affinché il servizio raggiunga adolescenti e giovani adulti, fascia a elevato bisogno e a basso ricorso spontaneo, condizione di equità peculiare di una regione giovane. ↑
008. Costo-efficacia distributiva: l'analisi indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, in quanto i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto; l'intervento è quindi favorevole all'equità, oltre che costo-efficace. ↑
009. Modulazione territoriale della copertura: per realizzare il potenziale di equità, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle periferie napoletane e alle province interne di Avellino e Benevento; un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un'allocazione ponderata per il bisogno li riduce. ↑
010. Mobilità e equità: nella Campania il canale della mobilità è, per questo intervento, una leva di equità solo modesta, poiché la fuga — pur fra le più elevate d'Italia — riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica e non la domanda psicologica territoriale; l'equità si gioca quindi prevalentemente sull'accesso interno, fra centro e periferie napoletane e fra area metropolitana e province interne. ↑
011. Rischio di iniquità inversa: se l'estensione del servizio privilegiasse, per facilità organizzativa, le aree già meglio servite, l'effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell'allocazione delle sedi e degli incarichi, nella fase di strutturazione a regime del servizio già attivo. ↑
012. Sintesi dell'equità: l'intervento è favorevole all'equità su entrambi gli assi del divario campano e sulla dimensione generazionale, a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno e che siano garantite la telepsicologia per le periferie e le aree interne e l'attenzione al disagio giovanile; la raccomandazione è di

adottare, nella strutturazione a regime, un'allocazione pro-equità che dia di più dove il bisogno è maggiore, consolidando ed estendendo i risultati già conseguiti dal servizio attivo. ↑

013. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; il servizio attuale, parziale e a finanziamento transitorio, come comparatore. ↑

014. ↑

015. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; il servizio attuale, parziale e a finanziamento transitorio, come comparatore. Metodo della revisione: la sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche (PRISMA 2020) e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE; sono considerati studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. ↑

016. Studio fondativo del modello collaborativo (IMPACT), pubblicato su JAMA nel 2002: circa il 50% dei pazienti trattati ha conseguito una riduzione di almeno il 50% dei sintomi a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. ↑

017. Meta-analisi su cinquantasette studi controllati (2012): l'integrazione della cura ha prodotto un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard rispetto alla cura usuale. ↑

018. Revisione di quarantadue implementazioni del modello (2024): riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 43% dell'ansia a sei mesi, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. ↑

019. Programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies), dati reali 2023-2024: tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile del 67,8% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su una scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno. ↑

020. Meta-analisi sulle cure integrate: coefficiente standardizzato dell'ordine di -0,11 sui sintomi depressivi, di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante quando applicato a una popolazione ampia. ↑

021. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. ↑

022. Cautela metodologica rilevante: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi (l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero); il valore economico del modello poggia in misura preponderante sui ritorni sociali, non sui risparmi sanitari diretti. Questa cautela è coerente con il profilo del caso economico campano, fondato anch'esso sulle ricadute sociali. ↑

023. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. ↑

024. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. ↑

025. ↑

026. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. Tre profili intrecciati: la fattibilità dell'intervento dipende dal presidio congiunto di un profilo giuridico (la competenza e la forma dell'atto), di un profilo organizzativo (l'assetto e la governance dell'istituzione) e di un profilo etico (le tutele a garanzia dei pazienti); lo studio li tratta unitariamente, poiché una debolezza in uno solo di essi comprometterebbe l'intera operazione. ↑
027. Profilo giuridico e riparto di competenza: la materia si colloca nella competenza legislativa concorrente in tema di tutela della salute. La sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — pronuncia fondativa per l'intera materia — è nata proprio dal giudizio sulla legge campana, di cui ha riconosciuto la legittimità, delimitando lo spazio della disciplina regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. La Campania ha quindi già esercitato, prima fra le regioni, il titolo a istituire il servizio con legge propria, in forma coordinata con la cornice nazionale. ↑
028. Stato legislativo della Campania: a differenza del Lazio, ancora privo di legge, la Campania dispone già della legge regionale 35 del 2020 e del regolamento attuativo 8 del 2022, in forza dei quali il servizio è attivo. La decisione giuridica rilevante non è quindi l'approvazione della legge istitutiva, già compiuta e validata, ma il suo consolidamento a regime: la stabilizzazione del finanziamento, oggi in parte transitorio, e il perfezionamento dell'inquadramento convenzionale, nel coordinamento con il testo unico nazionale in discussione. ↑
029. Inquadramento del rapporto di lavoro: la legge regionale 35 del 2020 ha già adottato il rapporto convenzionale su base libero-professionale, con iscrizione a un elenco aziendale previo corso di abilitazione regionale, per analogia con la medicina generale e la pediatria di libera scelta. Tale forma assicura flessibilità e prossimità, ma sconta l'assenza di un contratto collettivo nazionale di riferimento: la sua definizione, attesa dal testo unico nazionale, è condizione di stabilità e di tutela della continuità del rapporto. ↑
030. Livelli essenziali di assistenza e finanziamento: la psicologia di base nelle cure primarie non è ancora esplicitamente ricompresa nei livelli essenziali di assistenza nazionali. Il servizio campano è oggi finanziato in larga parte con risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute; la strutturazione a regime richiede il passaggio a un finanziamento regionale stabile, oggi reso possibile dall'uscita dal piano di rientro, mentre un futuro riconoscimento nei livelli essenziali rafforzerebbe ulteriormente la stabilità. ↑
031. Cornice degli standard territoriali: il Decreto Ministeriale 77 del 2022 definisce gli standard dell'assistenza territoriale e individua nelle Case della Comunità il fulcro dell'integrazione delle cure primarie; il servizio di psicologia di base vi si inserisce coerentemente, come uno dei livelli di risposta al bisogno della popolazione. ↑
032. Rapporto con i servizi specialistici: il servizio di psicologia di base precede e alleggerisce i Centri di Salute Mentale, intercettando e trattando i quadri lievi e moderati e indirizzando a essi i casi che richiedono cure specialistiche; l'integrazione, e non la sovrapposizione, è il principio che ne governa il rapporto con la rete esistente. ↑
033. Assetto organizzativo: la strutturazione del servizio nella Campania si misura con un sistema esteso e policentrico — sette Aziende Sanitarie Locali, tre nell'area metropolitana napoletana e quattro nelle altre province, numerose aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e IRCCS — e con l'assenza di un'azienda regionale unica, sicché il coordinamento è in capo alla Regione, con il supporto della società regionale per gli acquisti; garantire l'omogeneità attuativa fra le Aziende è la sfida organizzativa centrale. ↑
034. Governance della strutturazione: il consolidamento del servizio richiede una regia regionale che coordini le sette Aziende Sanitarie Locali, le aziende ospedaliere e gli IRCCS, l'Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei; tale regia è già esercitata dalla Regione

con il supporto dell'Osservatorio regionale istituito dalla legge, cui spetta definire indirizzi operativi uniformi e consolidare il sistema di monitoraggio comune. ↑

035. Ruolo dell'Ordine professionale: l'Ordine degli Psicologi della Campania, che conta quasi diecimila iscritti e ha accompagnato l'attuazione della legge, concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione e alla vigilanza deontologica; la sua collaborazione è condizione della qualità e dell'appropriatezza del servizio. ↑
036. Profilo etico, tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici; è una cautela che presidia l'intervento presso le fasce più fragili. ↑
037. Consenso e riservatezza: l'intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un'informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell'efficacia stessa del sostegno psicologico. ↑
038. Strumenti di intelligenza artificiale e quadro europeo: gli strumenti digitali eventualmente impiegati sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
039. Protezione dei dati personali: il trattamento è conforme alla normativa vigente, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑
040. Responsabilità professionale: il professionista resta pienamente responsabile delle decisioni cliniche, e gli strumenti di supporto, anche quelli basati sull'intelligenza artificiale, forniscono un ausilio non vincolante; la chiarezza sull'imputazione della responsabilità è condizione di un impiego sicuro e appropriato della tecnologia. ↑
041. Sintesi dei profili: i tre profili — giuridico, organizzativo ed etico — sono presidiati, e la condizione abilitante dell'intervento non è, per la Campania, l'approvazione della legge, già in vigore e validata dalla Corte Costituzionale, ma la stabilizzazione del finanziamento e la strutturazione a regime del servizio già attivo; è questo il passaggio da cui dipende il consolidamento del servizio pioniere, che il coordinamento con il futuro testo unico nazionale potrà rafforzare. ↑
042. Benchmark statunitense (Collaborative Care): modello a équipe integrata, validato da oltre novanta studi controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri. ↑
043. Esperienze italiane: la Campania è stata la prima regione d'Italia a istituire e attivare il servizio di psicologia di base, e i dati prodotti dal suo servizio attivo — migliaia di colloqui erogati già nei primi mesi di attività — costituiscono, accanto ai servizi avviati nelle altre regioni dotate di legge, la principale base di evidenza italiana sul modello. Tali dati derivano da un servizio ancora giovane e vanno consolidati e validati, ma rappresentano un patrimonio informativo proprio, distintivo della regione pioniera, che le esperienze fondate su campioni limitati e su letteratura grigia non offrivano. ↑
044. Trasferibilità: i risultati internazionali provengono da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale; la loro trasposizione richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche. ↑
045. Evidenza locale campana: a differenza del Lazio, privo di un servizio attivo, la Campania dispone già di un servizio operativo che produce dati di esito propri — prese in carico, prestazioni ed esiti raccolti dall'Osservatorio regionale — sicché l'evidenza locale non è soltanto prospettica, ma in parte già

disponibile. Lo studio poggia, per l'efficacia, sui benchmark internazionali e su questa base di dati propri in via di consolidamento, vantaggio peculiare della regione pioniera, e potrà corroborarsi ulteriormente man mano che il servizio si struttura a regime. ↑

046. Condizioni campane per la trasferibilità e la valutazione: la Campania dispone della tradizione operativa del servizio pioniere, dell'infrastruttura informatica sanitaria regionale e della rete delle Case della Comunità in costruzione; il vantaggio peculiare della regione è di poter corroborare i benchmark internazionali con i propri dati operativi, generando un'evidenza locale solida e non soltanto importata, e di poter perfezionare la rilevazione man mano che il servizio si struttura a regime. ↑
047. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative: il rapporto di 4:1 spesso citato e l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio sono semplificazioni a fini divulgativi; lo stesso vale per il rapporto di 2,5:1 talvolta richiamato in ambito regionale. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8:1-5,5:1. ↑
048. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. La Campania presenta un profilo finanziario in evoluzione favorevole: è uscita dal piano di rientro nel marzo 2026, dopo quasi vent'anni, riacquistando per la prima volta in due decenni margini di programmazione e capacità di investimento. Sul versante della mobilità sanitaria, la regione presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, ma la fuga si concentra nei ricoveri ospedalieri e nelle prestazioni ad alta complessità, non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. Ne consegue un saldo diretto lievemente negativo ma prossimo al pareggio — meno sfavorevole che in una regione dal sistema già efficiente, poiché il sistema campano, a lungo sotto-finanziato, presenta un consumo improprio più ampio da recuperare — mentre il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi. ↑
049. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (9,5%) e non estratti dai conti regionali certificati delle sette Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare prima della presentazione esterna. A differenza del Lazio, tuttavia, la Campania dispone già di un servizio attivo che produce dati operativi reali — prese in carico, prestazioni e relazioni annuali raccolte dall'Osservatorio regionale — sicché lo studio poggia, per l'efficacia, sui benchmark internazionali e su una base di dati propri in via di consolidamento, vantaggio peculiare della regione pioniera. ↑
050. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
051. Valutazione controfattuale d'impatto: poiché il servizio è già attivo ma in corso di estensione, il disegno può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di estensione delle sedi tra le sette Aziende Sanitarie Locali e i loro distretti — che hanno avviato il servizio in tempi differenziati — sono impiegati a fini valutativi, con il servizio già in funzione come linea di base. L'effetto causale è stimato con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico; la disponibilità di dati operativi reali rafforza l'identificazione, distinguendo la Campania dalle regioni prive di servizio attivo. ↑
052. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione, sette Aziende Sanitarie Locali (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, Salerno), aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie (Cardarelli, Santobono-Pausilipon, dei Colli, Federico II, Vanvitelli, Ruggi d'Aragona di Salerno, Moscati di Avellino) e IRCCS (Pascale), Ordine degli Psicologi della Campania, rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e atenei. La Campania non dispone

di un'azienda regionale unica: il coordinamento è in capo alla Regione, con il supporto della società regionale per gli acquisti e della piattaforma informativa regionale, mentre l'Osservatorio regionale già istituito esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. La sfida del governo non è quindi istituire il servizio, ma strutturarlo e dimensionarlo, garantendo l'omogeneità attuativa in un sistema esteso e policentrico. ↑

053. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce l'infrastruttura per la raccolta uniforme. ↑
054. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
055. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. ↑
056. ↑
057. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. I cinque casi della decisione di investimento pubblico: lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile; la convergenza dei cinque casi è condizione della solidità della decisione. ↑
058. Caso strategico: l'istituzione del servizio è coerente con la cornice nazionale degli standard territoriali, con la centralità delle Case della Comunità e con il Piano regionale di azioni per la salute mentale; nella Campania essa presenta una coerenza ulteriore, poiché consolida a regime il modello che la regione ha istituito per prima in Italia, dando stabilità a un servizio già attivo e validato sul piano costituzionale. ↑
059. Caso economico: rinvia ai risultati della valutazione economica — un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,9-5,5 a uno e una dominanza per paziente con elevata probabilità — nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di modesto disavanzo e un caso sociale fortemente positivo. ↑
060. Caso commerciale: il modello del rapporto convenzionale su base libero-professionale è già in esercizio e si avvale, nella Campania, di un bacino professionale ampio — l'Ordine regionale conta quasi diecimila iscritti — alimentato dagli atenei campani; la disponibilità di psicologi qualificati, già selezionati attraverso il corso di abilitazione regionale, non costituisce un vincolo all'estensione. ↑
061. Caso finanziario: il costo del servizio a regime — dell'ordine di 34, 50 e 67 milioni di euro nei tre scenari, pari allo 0,3-0,6% del finanziamento sanitario regionale — è sostenibile, tanto più che la Campania è uscita dal piano di rientro nel marzo 2026, riacquistando margini di programmazione; la sfida finanziaria propria è il passaggio dalle risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute, che oggi sostengono il nucleo attivo, a un finanziamento regionale stabile. ↑
062. Caso gestionale: la realizzabilità dipende da una regia regionale che, in assenza di un'azienda unica, coordini le sette Aziende Sanitarie Locali, le aziende ospedaliere e gli IRCCS, l'Ordine professionale, la medicina generale e la pediatria di libera scelta e gli atenei; tale regia è già esercitata con il supporto dell'Osservatorio regionale, cui spetta consolidare indirizzi uniformi e il monitoraggio comune. ↑

063. Dimensionamento a partire dal nucleo attivo: a differenza del Lazio, che deve dimensionare il servizio da zero, la Campania muove dal nucleo già attivo, dell'ordine di 146 psicologi, e lo estende verso un fabbisogno a regime dell'ordine di 1.210 psicologi nello scenario espansivo; l'estensione procede per gradi attraverso gli scenari conservativo, di base ed espansivo, consolidando un servizio già in funzione anziché istituirlo. ↑
064. Fasi di attuazione: poiché il servizio è già avviato, l'attuazione si articola in una fase di consolidamento del nucleo attivo e di stabilizzazione del finanziamento; una fase di estensione, nella quale la copertura si amplia progressivamente fra le sette Aziende; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato al fabbisogno. La progressione differenziata dell'estensione fra le Aziende, che hanno avviato il servizio in tempi diversi, coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F. ↑
065. Reclutamento e formazione: l'estensione richiede il reclutamento e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino professionale ampio, il corso di abilitazione regionale già previsto dalla legge e gli atenei campani costituiscono una base favorevole, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze. ↑
066. Cronoprogramma: l'attuazione si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; a differenza del Lazio, l'estensione non è subordinata all'approvazione di una legge — già in vigore — ma alla stabilizzazione del finanziamento, oggi resa possibile dall'uscita dal piano di rientro, sicché la Campania muove da una posizione di partenza più avanzata. ↑
067. Sostenibilità finanziaria: la leva della sostenibilità, nella Campania, è la stabilizzazione del finanziamento — il passaggio dalle risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute a risorse regionali stabili — e il dimensionamento progressivo del servizio; i margini riacquistati con l'uscita dal piano di rientro rendono praticabile l'investimento, mentre l'eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe in futuro la stabilità. ↑
068. Sostenibilità organizzativa: la sfida è garantire l'omogeneità attuativa fra le sette Aziende Sanitarie Locali in un sistema esteso e policentrico privo di un'azienda regionale unica; la sostenibilità organizzativa dipende dalla forza della regia regionale, dal ruolo dell'Osservatorio regionale e dalla chiarezza degli indirizzi operativi. ↑
069. Monitoraggio dell'attuazione: l'avanzamento è seguito mediante indicatori di processo — sedi attivate, incarichi conferiti, prese in carico — raccolti attraverso il flusso informativo già avviato dall'Osservatorio regionale, di cui la strutturazione deve garantire l'uniformità e la completezza fra le sette Aziende. ↑
070. Rischi principali dell'attuazione: la disomogeneità attuativa fra le Aziende in un sistema policentrico; la difficoltà di coordinamento in assenza di un'azienda unica; e soprattutto la dipendenza del servizio dalle risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute, che introduce un'incertezza finanziaria fino alla stabilizzazione su risorse regionali, cui si aggiunge l'assenza di un contratto collettivo nazionale. ↑
071. Mitigazioni: i rischi sono fronteggiati con una regia regionale forte e indirizzi operativi uniformi, con la progressione differenziata dell'estensione fra le Aziende che consente un apprendimento progressivo, e con un'allocatione pro-equità che orienta l'estensione verso le aree a maggiore bisogno; la stabilizzazione del finanziamento su risorse regionali e il sostegno dell'Ordine professionale concorrono a ridurre l'incertezza. ↑
072. Sintesi dell'attuazione: l'intervento è attuabile e sostenibile, e la leva propria della Campania è la stabilizzazione del finanziamento e l'estensione dimensionata di un servizio già attivo; la regione muove da un nucleo già operativo, da un bacino professionale ampio e dai margini riacquistati con l'uscita dal piano di rientro, sicché le condizioni di fattibilità sono complessivamente favorevoli. ↑

073. Struttura per età fra le più giovani d'Italia: l'età media è dell'ordine di 44,5 anni, fra le più basse del Paese, pur in lieve crescita. La distribuzione interna è disomogenea: le province di Caserta e Napoli sono le più giovani (età media dell'ordine di 43,6 e 43,7 anni), mentre Benevento e Avellino sono le più anziane (47,1 e 46,9 anni). La componente straniera concorre al ringiovanimento della popolazione. ↑
074. Componente straniera dell'ordine del 5,0% dei residenti (276.531 persone), nettamente inferiore alla media nazionale e fra le più contenute fra le regioni esaminate; ciò rende la dimensione della competenza culturale meno centrale che in altre regioni, pur restando rilevante nelle aree di maggiore insediamento. ↑
075. Distribuzione territoriale fortemente concentrata: la sola provincia di Napoli raccoglie circa il 53% dei residenti, sfiorando i tre milioni di abitanti; segue la provincia di Salerno, con oltre un milione di residenti, pari a circa il 19%; le restanti tre province — Caserta, Avellino e Benevento — raccolgono circa il 28%. ↑
076. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato la densissima area metropolitana napoletana, fra le più popolate d'Europa, con estese aree di deprivazione socio-economica; dall'altro le province interne di Avellino e Benevento, più anziane e a minore densità, dove la rarefazione dei servizi e le distanze acuiscono le difficoltà di accesso. ↑
077. ↑
078. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato la densissima area metropolitana napoletana, fra le più popolate d'Europa, con estese aree di deprivazione socio-economica; dall'altro le province interne di Avellino e Benevento, più anziane e a minore densità, dove la rarefazione dei servizi e le distanze acuiscono le difficoltà di accesso. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Nella Campania tale definizione è già recepita nella legge regionale 35 del 2020 e nel relativo regolamento attuativo. ↑
079. ↑
080. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato la densissima area metropolitana napoletana, fra le più popolate d'Europa, con estese aree di deprivazione socio-economica; dall'altro le province interne di Avellino e Benevento, più anziane e a minore densità, dove la rarefazione dei servizi e le distanze acuiscono le difficoltà di accesso. Definizione: lo psicologo di base è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Nella Campania tale definizione è già recepita nella legge regionale 35 del 2020 e nel relativo regolamento attuativo. Impianto della valutazione economica: lo studio impiega congiuntamente l'analisi costo-utilità, che rapporta il costo agli anni di vita ponderati per la qualità; l'analisi di impatto sul bilancio, che misura la sostenibilità finanziaria esercizio per esercizio; e l'analisi del ritorno sociale, che valuta il valore generato per la collettività. La doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società distingue rigorosamente i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali più ampie. ↑
081. Costo del servizio: assumendo un costo medio annuo per incarico dell'ordine di 55.000 euro, comprensivo degli oneri, i tre scenari di copertura corrispondono a un costo annuo a regime dell'ordine di 34 milioni di euro nello scenario conservativo (circa 610 psicologi), 50 milioni nello scenario di base (circa 910) e 67 milioni nello scenario espansivo (circa 1.210), nel modello del rapporto convenzionale su base libero-professionale già adottato dalla legge regionale. ↑
082. Scenari di copertura del fabbisogno: lo scenario conservativo, di base ed espansivo rappresentano gradi crescenti di copertura della popolazione con disagio comune, verso la copertura piena del fabbisogno. Il servizio attualmente attivo, dell'ordine di 146 psicologi, in larga parte sostenuto da risorse transitorie del

Piano Nazionale Equità in Salute, costituisce un nucleo iniziale, inferiore allo stesso scenario conservativo; gli scenari qui considerati rappresentano il regime e non la prima fase di avvio. ↑

083. Risparmio diretto sugli accessi impropri al pronto soccorso: dell'ordine di 5, 7 e 10 milioni di euro l'anno nei tre scenari, per effetto della riduzione degli accessi per cause psichiatriche e somatoformi intercettabili a livello territoriale, particolarmente rilevanti in un sistema storicamente sotto-dotato. ↑
084. Risparmio diretto sulla spesa farmaceutica: dell'ordine di 5, 8 e 12 milioni di euro l'anno, per effetto della riduzione delle prescrizioni inappropriate di antidepressivi e ansiolitici nei quadri lievi, in favore dell'intervento psicologico. ↑
085. Risparmio diretto su ricoveri e specialistica: dell'ordine di 13, 20 e 34 milioni di euro l'anno, per effetto della riduzione di ricoveri evitabili, consulti specialistici ripetuti e accertamenti inappropriate connessi a disagio non riconosciuto; il margine di recupero è ampio in ragione della sotto-dotazione storica del sistema. ↑
086. Recupero della mobilità sanitaria: per la Campania il contributo è modesto, dell'ordine di 4, 7 e 10 milioni di euro l'anno nei tre scenari, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. La regione presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, ma la fuga si concentra nei ricoveri ospedalieri e nelle prestazioni chirurgiche ad alta complessità, non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché questo canale — che per altri interventi sarebbe una leva centrale di una regione debitrice del Mezzogiorno — contribuisce qui solo per la quota di domanda impropria, prevalentemente somatoforme, che un primo livello territoriale può trattenere. ↑
087. ↑
088. Recupero della mobilità sanitaria: per la Campania il contributo è modesto, dell'ordine di 4, 7 e 10 milioni di euro l'anno nei tre scenari, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. La regione presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, ma la fuga si concentra nei ricoveri ospedalieri e nelle prestazioni chirurgiche ad alta complessità, non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché questo canale — che per altri interventi sarebbe una leva centrale di una regione debitrice del Mezzogiorno — contribuisce qui solo per la quota di domanda impropria, prevalentemente somatoforme, che un primo livello territoriale può trattenere. Finalità del monitoraggio e della valutazione ex post: rendere conto dell'impiego delle risorse, apprendere dall'esperienza e correggere il corso dell'attuazione; la valutazione non è un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l'istituzione del servizio si traduce in apprendimento istituzionale, ed è ancorata a una clausola valutativa. ↑
089. Impianto secondo i tre livelli di struttura, processo ed esito: la valutazione distingue le condizioni e le risorse del servizio (struttura), le attività e il loro svolgimento (processo) e i risultati conseguiti (esito), in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti. ↑
090. Disegno controfattuale su servizio attivo: poiché nella Campania il servizio è già attivo ma in corso di estensione, la valutazione d'impatto può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di estensione delle sedi tra le sette Aziende Sanitarie Locali e i loro distretti — che hanno avviato il servizio in tempi differenziati — sono impiegati a fini valutativi, con il servizio già in funzione come linea di base; la disponibilità di dati operativi reali, già raccolti dall'Osservatorio regionale, rafforza l'identificazione dell'effetto. ↑
091. Linea di base dalla progressione differenziata: a differenza del Lazio, la Campania non dispone di una linea di base anteriore all'avvio per le aree già servite, ma il diverso grado di estensione fra le sette Aziende e i dati operativi già raccolti consentono di costruire termini di confronto interni; la stima dell'effetto poggia così su dati reali, vantaggio che le regioni prive di servizio attivo non possiedono. ↑

092. Metodi di stima dell'effetto: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze, che confronta l'evoluzione delle aree già attivate con quella delle aree non ancora attivate, e con il metodo del controllo sintetico, che costruisce un termine di confronto a partire dai dati osservati; la progressione differenziata dell'estensione fra le Aziende fornisce la variazione necessaria all'identificazione. ↑
093. Indicatori di struttura: numero di sedi attivate nelle Case della Comunità, incarichi conferiti, ore di servizio disponibili, dotazione tecnologica e copertura territoriale rispetto al fabbisogno; misurano la capacità effettivamente installata. ↑
094. Indicatori di processo: prese in carico, tempo di attesa al primo colloquio, numero di colloqui per persona, tasso di invio appropriato ai servizi specialistici e aderenza ai percorsi clinici; misurano il funzionamento del servizio. ↑
095. Indicatori di esito clinico: quota di miglioramento e tasso di recupero, misurati con gli strumenti validati nei soli punteggi complessivi, e remissione dei quadri trattati; misurano il beneficio diretto per le persone. ↑
096. Indicatori di esito di sistema: accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche, prescrizioni di psicofarmaci nei quadri lievi, ricoveri evitabili e consulti specialistici impropri; misurano l'effetto dell'intervento sul resto del sistema. ↑
097. Indicatori economici: costo del servizio, risparmi diretti per canale, ricadute economico-sociali e rapporto beneficio-costi, calcolati su dati reali man mano disponibili; consentono di verificare ex post le stime dello studio e di sostituire progressivamente i valori ricostruiti con quelli effettivi. ↑
098. Indicatori di equità: copertura e accesso disaggregati per area — centro e periferie napoletane, province interne di Avellino e Benevento — e per fasce di età, con attenzione al disagio giovanile particolarmente rilevante in una regione giovane; verificano che il servizio riduca i divari anziché accrescerli, coerentemente con l'allocazione pro-equità raccomandata. ↑
099. Indicatori di qualità: soddisfazione degli utenti, appropriatezza delle prese in carico e degli invii, continuità del rapporto e qualità percepita della relazione; integrano la misurazione degli esiti con la dimensione dell'esperienza. ↑
100. Indicatori di mobilità: per la Campania sono monitorati ma costituiscono un esito atteso solo modesto, poiché la fuga — pur fra le più elevate d'Italia — riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica e non la domanda psicologica territoriale; la loro rilevazione serve a documentare la sola frazione territorialmente intercettabile, non un effetto principale. ↑
101. Batteria complessiva di indicatori: l'insieme è organizzato in otto categorie — struttura, processo, esito clinico, esito di sistema, economici, equità, qualità e mobilità — per un totale dell'ordine di cinquantotto indicatori, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile della rilevazione; la batteria è comune alla serie e adattata al contesto campano. ↑
102. Cruscotto regionale di monitoraggio: gli indicatori confluiscono in un cruscotto aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; in assenza di un'azienda regionale unica, la titolarità del cruscotto è in capo alla Regione e all'Osservatorio regionale già istituito, che ne assicurano l'alimentazione uniforme da parte delle sette Aziende. ↑
103. Clausola valutativa: lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa; a differenza del Lazio, che deve inserirla nella futura legge, la Campania dispone già di una previsione di rendicontazione nella legge regionale 35 del 2020 e nell'Osservatorio regionale, sicché il compito non è introdurla ma rafforzarla e renderla pienamente operativa, impegnando la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio sull'attuazione e sui risultati. ↑

104. Flusso informativo: la raccolta dei dati di processo e di esito poggia su un flusso informativo già avviato dall'Osservatorio regionale attraverso le relazioni annuali degli psicologi, di cui la strutturazione deve garantire l'uniformità, la completezza e l'interoperabilità con la piattaforma informativa sanitaria regionale, consolidando un sistema in funzione anziché istituirlo. ↑
105. Tempi della valutazione: la valutazione si articola in un monitoraggio in itinere, che accompagna l'estensione del servizio attivo e ne osserva la progressione differenziata fra le Aziende; e in una valutazione ex post, che misura l'effetto a regime e ne verifica la sostenibilità; rispetto al Lazio manca una linea di base anteriore all'avvio per le aree già servite, compensata dai dati operativi reali già disponibili. ↑
106. Sintesi del monitoraggio: la valutazione è la condizione per trasformare la strutturazione del servizio in apprendimento, e la Campania può fondarla su dati operativi reali già disponibili; perché ciò si realizzi, la clausola valutativa già prevista dalla legge va rafforzata e resa operativa e il flusso informativo dell'Osservatorio va consolidato e uniformato, valorizzando la condizione di regione pioniera. ↑
107. Ricadute economico-sociali per la collettività: dell'ordine di 105, 200 e 300 milioni di euro l'anno nei tre scenari, comprensive del recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo — di particolare rilievo in una regione giovane — del valore del benessere recuperato e del minor carico assistenziale sulle famiglie; sono stimate con criteri conservativi. ↑
108. Ritorno complessivo annuo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali: dell'ordine di 132, 242 e 366 milioni di euro nei tre scenari. Detratto il costo del servizio, il saldo complessivo per la collettività è ampiamente positivo, dell'ordine di +98, +192 e +299 milioni di euro l'anno. ↑
109. Rapporto beneficio-costi complessivo: dell'ordine di 3,9 a uno nello scenario conservativo, 4,8 a uno in quello di base e 5,5 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale di 3,8-5,5 a uno adottata dallo studio e coerente con le stime metodologicamente fondate della letteratura. ↑
110. Distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico: è il punto che lo studio tiene fermo per la Campania e che ne governa la lettura. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, prossimo al pareggio, poiché i risparmi diretti quasi coprono il costo del servizio e il canale della mobilità è modesto. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il solo ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe. La decisione va assunta riconoscendo che si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto molto contenuto per il bilancio sanitario. ↑
111. Tabella economica consolidata: riepiloga, per i tre scenari, il costo del servizio, i risparmi diretti per canale, il saldo diretto, le ricadute sociali, il ritorno complessivo, il saldo complessivo e il rapporto beneficio-costi; è lo strumento sintetico per la decisione e distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale. ↑
112. Analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni, sconto del 3%): il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 euro del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: meno costoso e più efficace. Il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. ↑
113. Analisi di sensibilità probabilistica (diecimila simulazioni): l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, e dominante nell'84,6%; il beneficio monetario netto medio per paziente è dell'ordine di 7.815 euro, con un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. La robustezza del risultato clinico-economico per paziente è elevata, distintamente dall'incertezza sulle grandezze aggregate di sistema. ↑

114. Impatto sul bilancio e sostenibilità: il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta del finanziamento sanitario regionale, dell'ordine dello 0,3% nello scenario conservativo e dello 0,6% in quello espansivo. La sostenibilità è favorita dalla circostanza che la Campania è uscita dal piano di rientro nel marzo 2026, dopo quasi vent'anni, riacquistando margini di programmazione e capacità di investimento che per due decenni non aveva avuto; la strutturazione a regime richiede peraltro il passaggio dalle risorse transitorie del Piano Nazionale Equità in Salute, oggi prevalenti, a un finanziamento regionale stabile, oggi reso possibile. ↑
115. Lacuna dei dati e sua mitigazione: le grandezze economiche sono allo stato in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione (9,5%) e non estratte dai conti certificati delle sette Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere; a differenza del Lazio, tuttavia, la Campania dispone già di un servizio attivo che produce dati operativi reali, raccolti dall'Osservatorio regionale, sicché la stima poggia sui benchmark internazionali e su una base di dati propri in via di consolidamento. L'estrazione dei dati certificati resta la priorità da completare prima della presentazione esterna. ↑
116. Sintesi della valutazione economica: il caso diretto è prudente e prossimo al pareggio per il bilancio sanitario; il caso sociale è robusto e fortemente positivo; il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità. La coerenza con la cautela metodologica già enunciata — i risparmi sanitari diretti non sono certi sul piano statistico — è piena: il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali, non in un risparmio di bilancio che lo studio si astiene dal rivendicare. ↑
117. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 1.116.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato nonostante la presenza del servizio pioniere; poiché il servizio è già attivo ma parziale, l'intervento va dimensionato a partire dal nucleo esistente, dell'ordine di 146 psicologi, ed esteso verso il fabbisogno a regime. ↑
118. Modello organizzativo: lo psicologo di base opera nelle Case della Comunità e nei distretti sanitari, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impianto della legge regionale 35 del 2020, che prevede almeno due psicologi per distretto sanitario, l'istituzione di un elenco aziendale degli psicologi di base presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale e un rapporto convenzionale su base libero-professionale. Nel modello campano il servizio è già attivo nelle sette Aziende Sanitarie Locali; a differenza del Veneto, la Regione non dispone di un'azienda regionale unica, e il coordinamento è in capo alla Regione con il supporto dell'Osservatorio regionale, sicché l'omogeneità attuativa fra le sette Aziende — tre delle quali nell'area metropolitana napoletana — è la sfida organizzativa principale. ↑
119. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
120. Percorso clinico: accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista; valutazione iniziale e progetto clinico individuale; ciclo di colloqui brevi e programma di sostegno personalizzato; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. Il percorso è già operativo nelle Aziende campane e affronta i quadri più frequenti — sintomatologia ansioso-depressiva, problemi di adattamento, fasi del ciclo di vita, disagi emotivi transitori, problematiche psicosomatiche. ↑
121. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
122. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑

123. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
124. ↑
125. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). Funzione della sintesi: la parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo, impiegando l'analisi multi-criterio per integrare in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie; non somma grandezze disomogenee, ma le pondera secondo criteri espliciti, rendendo verificabile il passaggio dall'evidenza alla raccomandazione. ↑
126. Sintesi per dominio: il bisogno è ampio e radicato in una regione giovane e fortemente accentrata su Napoli; l'efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida e, per la Campania, già integrata da dati operativi reali del servizio attivo; il quadro economico distingue un caso finanziario di modesto disavanzo prossimo al pareggio da un caso sociale fortemente positivo; l'equità è favorevole su un doppio asse territoriale e sulla dimensione generazionale; la fattibilità è quella di una strutturazione a regime di un servizio già attivo; il monitoraggio può fondarsi su dati reali già disponibili. La convergenza dei domini sostiene una raccomandazione favorevole. ↑
127. Metodo dell'analisi multi-criterio: i criteri di valutazione sono otto, ciascuno con un peso esplicito — efficacia clinica, costo-efficacia e ritorno economico, impatto sul bilancio e sostenibilità, equità, valore sociale, fattibilità, robustezza dell'evidenza e coerenza strategica — e l'intervento è confrontato con l'alternativa del non intervento attribuendo a ciascuno un punteggio, la cui media ponderata fornisce il giudizio complessivo. ↑
128. Criteri e pesi adottati: efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno economico 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell'evidenza 10%, coerenza strategica 5%; la struttura dei pesi è comune a tutti gli studi della serie, a garanzia di confrontabilità. ↑
129. Punteggio dell'intervento: la media ponderata dei punteggi attribuiti all'intervento è dell'ordine di 80,6 su 100, sostenuta dai punteggi elevati nel valore sociale, nell'equità, nella coerenza strategica — la più alta della serie, propria della regione pioniera — e nel ritorno economico, e contenuta dal punteggio più basso nella robustezza dell'evidenza, che, pur superiore a quello del Lazio grazie ai dati propri, riflette la natura ancora giovane del servizio. ↑
130. Punteggio del non intervento: l'alternativa di non strutturare il servizio a regime ottiene una media ponderata dell'ordine di 39,2 su 100; essa è penalizzata in tutti i criteri sostanziali — efficacia, equità, valore sociale, ritorno — e è sostenuta soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, che però nella Campania appare oggi meno giustificata, vista la disponibilità di margini finanziari riacquistati con l'uscita dal piano di rientro. ↑
131. Interpretazione del confronto: l'intervento prevale nettamente sul non intervento, con uno scarto dell'ordine di quarantuno punti; il punteggio dell'intervento si colloca fra i più elevati delle regioni esaminate di recente, riflettendo la posizione di regione pioniera — prima per legge e già dotata di servizio attivo e di dati propri — pur scontando un caso finanziario diretto modesto e la giovane età del servizio. ↑
132. Robustezza della raccomandazione: la prevalenza dell'intervento si mantiene anche facendo variare i pesi dei criteri entro intervalli ragionevoli; nessuna combinazione plausibile dei pesi rovescia il giudizio, sicché la raccomandazione è robusta rispetto alle scelte valoriali sottostanti alla ponderazione. ↑

133. Raccomandazione principale: si raccomanda di strutturare a regime il servizio di psicologia di base già attivo, stabilizzandone il finanziamento — dal sostegno transitorio del Piano Nazionale Equità in Salute a risorse regionali stabili — e dimensionandolo verso la copertura piena del fabbisogno; è la decisione che la Campania, prima regione d'Italia ad aver istituito il servizio per legge, è chiamata a compiere per consolidare il proprio primato in un servizio a regime. ↑
134. Dimensionamento raccomandato: si raccomanda di muovere dal nucleo già attivo, dell'ordine di 146 psicologi, e di procedere per gradi verso lo scenario conservativo, dell'ordine di 610 psicologi, quindi verso quello di base, dell'ordine di 910, e infine verso quello espansivo, dell'ordine di 1.210, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità. ↑
135. Condizioni della raccomandazione: il rafforzamento e la piena operatività della clausola valutativa già prevista dalla legge, l'adozione di un'allocazione pro-equità verso le periferie napoletane, le province interne e il disagio giovanile, una regia regionale forte affiancata dall'Osservatorio in assenza di un'azienda unica e il consolidamento del flusso informativo già avviato sono le condizioni che trasformano la raccomandazione in un'attuazione efficace e valutabile. ↑
136. Lacuna da colmare prima della presentazione esterna: l'estrazione dei conti certificati delle sette Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere e il consolidamento e l'uniformazione del flusso dei dati di esito già raccolti dall'Osservatorio sono le priorità che consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive, valorizzando i dati propri della regione pioniera. ↑
137. Distinzione cardine ribadita: la decisione va assunta riconoscendo che il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, mentre il caso economico complessivo, comprensivo delle ricadute sociali, è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto per il bilancio, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto. ↑
138. Collocazione nella serie regionale: lo studio sulla Campania è il nono della serie, dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria e Lazio, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, la Campania occupa una posizione fondativa, quella della regione pioniera che per prima ha istituito il servizio per legge — con una disciplina validata dalla Corte Costituzionale, la cui pronuncia è richiamata da tutti gli studi della serie — e che oggi è chiamata a portarlo a regime. ↑
139. Avvertenza conclusiva sulle semplificazioni: lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico — il rapporto di quattro a uno, il moltiplicatore per dieci, il rapporto di due e mezzo a uno — e adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, coerente con le stime metodologicamente fondate; è una scelta di credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica. ↑
140. Conclusione: la decisione che lo studio sostiene è di strutturare a regime il servizio di psicologia di base già attivo, stabilizzandone il finanziamento, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno e rendendo pienamente operativa la clausola valutativa; per la Campania, prima regione d'Italia ad aver istituito il servizio, ciò significa consolidare un primato normativo in un servizio stabile e a regime, a beneficio della popolazione. ↑
141. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale. A differenza del Lazio, che progetta il flusso da zero, la Campania dispone già di un flusso informativo avviato — le relazioni annuali raccolte dall'Osservatorio — di cui la strutturazione a regime deve garantire l'uniformità e la completezza fra le sette Aziende, consolidando un sistema già in funzione anziché istituirlo ex novo. ↑

142. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑
143. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
144. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
145. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: nella Campania sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle estese periferie dell'area metropolitana napoletana e nelle province interne di Avellino e Benevento, più anziane e a minore densità, dove le distanze e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; tali strumenti sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza. ↑
146. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
147. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso gli atenei campani — Federico II, Vanvitelli, Salerno — e gli altri atenei regionali); post-universitario specialistico (formazione dedicata alla psicologia di base e alle cure primarie, comprensiva della competenza per il disagio giovanile, particolarmente rilevante in una regione giovane, e per l'età anziana nelle province interne); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). La Campania presenta qui un elemento distintivo: la legge regionale prevede già un corso semestrale di abilitazione regionale per l'iscrizione agli elenchi aziendali, base formativa propria del servizio pioniere. ↑
148. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. ↑
149. ↑
150. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. Ruolo della modellazione: poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l'orizzonte direttamente osservabile, lo studio proietta costi ed esiti nel tempo mediante un modello decisionale, e ne governa l'incertezza con tecniche deterministiche e probabilistiche; la modellazione non genera certezze, ma rende esplicite e verificabili le assunzioni. ↑
151. Struttura del modello di Markov: la storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%; il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. ↑
152. Parametri principali del modello: a ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita; il costo per ciclo è dell'ordine di 40 euro per lo stato di recupero e di 700 euro per la cronicità, con l'intervento che comporta un costo una tantum dell'ordine di 300 euro; le grandezze sono trattate come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l'incertezza. ↑
153. Esito del caso base: l'intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell'ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità rispetto al comparatore; il risultato è robusto rispetto alle variazioni dei singoli parametri entro intervalli plausibili. ↑

154. Analisi di sensibilità deterministica a un parametro per volta: la variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — entro intervalli plausibili non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. ↑
155. ↑
156. Analisi di sensibilità deterministica a un parametro per volta: la variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — entro intervalli plausibili non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudentiale per l'ottimismo delle stime. ↑
157. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
158. Quadro economico consolidato per la Campania (Parte E): a regime, da circa 610 a circa 1.210 psicologi, costo del servizio di 34-67 milioni, risparmi diretti di 27-66 milioni, ricadute sociali di 105-300 milioni; il saldo diretto è lievemente negativo ma prossimo al pareggio, il saldo complessivo fortemente positivo, con rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno. ↑
159. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
160. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio; nella Campania, poiché il servizio è già attivo, il flusso è in parte avviato attraverso le relazioni annuali dell'Osservatorio regionale, e la strutturazione deve garantirne l'uniformità e la completezza fra le sette Aziende. ↑
161. Valori regionali di ancoraggio per la Campania: popolazione di 5.582.337 abitanti (Censimento ISTAT 2024), pari a circa il 9,5% del totale nazionale, in lieve calo per saldi naturale e migratorio interno negativi, fortemente concentrata sulla provincia di Napoli (circa il 53%); struttura per età fra le più giovani d'Italia (età media circa 44,5 anni); componente straniera contenuta (circa 5,0%); finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 11-12 miliardi di euro, con uscita dal piano di rientro nel marzo 2026 e margini di programmazione riacquistati; saldo di mobilità fra i più passivi d'Italia ma con fuga concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica, sicché il canale di recupero è modesto; fabbisogno a regime fino a circa 1.210 psicologi nello scenario espansivo. ↑
162. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione campana (9,5%), e non estratti dai conti regionali certificati; i dati da acquisire presso le sette Aziende Sanitarie Locali e le aziende ospedaliere sono elencati nella tabella seguente. A differenza del Lazio, nella Campania la loro mancanza è in parte mitigata dai dati operativi reali del servizio attivo, raccolti dall'Osservatorio regionale. ↑
163. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑
164. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni agli studi pugliese, lombardo, veneto, emiliano-romagnolo, piemontese, toscano, ligure e laziale, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑

165. Analisi di sensibilità probabilistica su diecimila simulazioni: l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. ↑
166. Curva di accettabilità: alla soglia convenzionale di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è prossima al 90%, e cresce ulteriormente per soglie superiori; già a soglie molto inferiori l'intervento mantiene un'elevata probabilità di convenienza. ↑
167. Analisi di scenario: i tre scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; il servizio attualmente attivo, dell'ordine di 146 psicologi e in larga parte sostenuto da risorse transitorie, corrisponde a un nucleo iniziale inferiore allo scenario conservativo, e costituisce la prima tappa di un percorso di estensione progressiva verso la copertura piena. ↑
168. Incertezza sulle grandezze aggregate: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce esplicitamente e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema. ↑
169. Disegno della verifica empirica: poiché nella Campania il servizio è già attivo ma in corso di estensione, la verifica controfattuale può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di estensione delle sedi tra le sette Aziende Sanitarie Locali e i loro distretti — che hanno avviato il servizio in tempi differenziati — sono impiegati a fini valutativi, con il servizio già in funzione come linea di base. La disponibilità di dati operativi reali, già raccolti dall'Osservatorio regionale, rafforza l'identificazione dell'effetto, distinguendo la Campania dalle regioni prive di servizio attivo. ↑
170. Metodi della verifica empirica: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, a partire dai dati già disponibili del servizio attivo e dalla progressione differenziata dell'estensione fra le sette Aziende, che fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto. ↑
171. Valore dell'informazione e priorità di ricerca: l'analisi del valore atteso dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione campana, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle sette Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere e il consolidamento e l'uniformazione del flusso dei dati di esito già raccolti dall'Osservatorio regionale. ↑
172. ↑
173. La struttura del corpus replica quella adottata per le altre regioni della serie, così da consentire il confronto sistematico fra i contesti regionali. Le differenze di contenuto fra le versioni regionali riflettono le condizioni specifiche di ciascuna regione — in Basilicata, la fase anteriore all'istituzione del servizio, l'equilibrio finanziario fragile non sottoposto a piano di rientro, il peso dell'emigrazione sanitaria, la struttura demografica anziana e la dispersione insediativa — e non modificano l'impianto metodologico, che è invariante. ↑
174. La compresenza di due proposte di legge regionali, depositate da forze politiche diverse e convergenti nell'obiettivo, costituisce un elemento favorevole alla costruzione di un consenso ampio attorno all'istituzione del servizio. Lo studio non prende posizione sul merito politico delle proposte, ma offre la base analitica perché la scelta legislativa, qualunque ne sia la forma, sia informata dall'evidenza sul bisogno, sull'efficacia e sulla sostenibilità. ↑

175. La formazione del personale e l'integrazione delle tecnologie costituiscono, nel progetto complessivo, un asse di lavoro autonomo, oggetto di uno studio dedicato. In questa sede essi sono trattati come componenti del modello organizzativo del servizio, nella misura in cui ne condizionano la qualità, l'efficacia e la sostenibilità. Il dimensionamento economico della formazione è considerato nella Parte E fra i costi del servizio, e il suo rendimento è valutato fra i fattori di efficienza. ↑
176. La graduazione dell'evidenza secondo il metodo GRADE e la distinzione fra uso qualitativo dei benchmark e modellazione quantitativa costituiscono le due principali garanzie di prudenza della valutazione clinica. Esse implicano che le stime quantitative di efficacia utilizzate nelle parti economiche siano da intendersi come stime centrali entro bande di incertezza, e non come valori certi, e che le conclusioni dello studio siano formulate con una forza proporzionata alla qualità dell'evidenza disponibile. ↑
177. Le stime economiche sono espresse mediante bande prudenziali e sono calibrate sulla popolazione regionale e sul fondo sanitario regionale. Esse sono sottoposte ad analisi di sensibilità nella Parte F, che ne verifica la robustezza rispetto alla variazione dei parametri. La distinzione fra caso finanziario e caso economico, e fra risparmi diretti e ricadute sociali, è mantenuta rigorosamente in ogni tabella, coerentemente con il principio metodologico dichiarato nella Parte A. ↑
178. I parametri quantitativi del modello — il risparmio per paziente di 1.304 euro, il guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità, la probabilità di costo-efficacia dell'88,9 per cento e di dominanza dell'84,6 per cento alla soglia di 30.000 euro, il beneficio netto medio di 7.815 euro con intervallo di confidenza fra -5.736 e +21.501 euro — sono fondati sull'efficacia clinica documentata e sono invarianti rispetto al contesto regionale. La loro applicazione alla Basilicata è mediata dagli scenari di copertura, che ne traducono l'effetto sulla popolazione regionale in modo prudenziale. ↑
179. La valutazione dell'impatto distributivo richiede che il monitoraggio del servizio, descritto nella Parte L, rilevi indicatori disaggregati per condizione sociale e per collocazione territoriale, così da verificare che il servizio raggiunga effettivamente i gruppi a maggiore bisogno e da correggerne la progettazione ove ciò non avvenga. In assenza di tale disaggregazione, l'obiettivo di equità resterebbe un'enunciazione non verificabile. ↑
180. Il rispetto dei limiti posti dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 241 del 2021 è la condizione di legittimità più stringente per la legge regionale istitutiva del servizio. La fase anteriore all'istituzione in cui si trova la Basilicata consente di costruire il servizio in conformità a tali limiti fin dall'origine, evitando il rischio di una successiva censura e valorizzando le soluzioni giuridiche già sperimentate dalle regioni che hanno affrontato il medesimo vincolo. ↑
181. Il percorso attuativo per fasi, calibrato sulla capacità finanziaria e organizzativa della regione e sull'evidenza progressivamente prodotta, è la traduzione operativa della logica di gradualità che attraversa lo studio. Esso consente di avviare il servizio con un impegno contenuto e sostenibile, di verificarne gli esiti sul campo e di accrescerne la portata in modo governato, riducendo i rischi connessi a un dispiegamento immediato su larga scala in un contesto di risorse limitate. ↑
182. L'inclusione di una clausola valutativa nella legge regionale istitutiva del servizio è la garanzia che la valutazione ex post sia effettivamente condotta e utilizzata. La fase anteriore all'istituzione in cui si trova la Basilicata consente di incorporare gli strumenti della valutazione — gli obiettivi misurabili, gli indicatori, i tempi, la restituzione — direttamente nel testo istitutivo, costruendo un servizio valutabile per disegno e allineato all'impianto adottato dalle altre regioni della serie, così da consentire il confronto interregionale. ↑
183. Il punteggio dell'analisi multi-criterio e le quantificazioni economiche sono strumenti di sintesi che non sostituiscono la valutazione complessiva, ma la rappresentano in forma sintetica. La raccomandazione finale si fonda sulla convergenza di tutte le analisi di dominio, e la sua forza è proporzionata alla qualità

dell'evidenza disponibile, graduata secondo il metodo dichiarato nella Parte A. La collocazione dello studio nella serie regionale consente di inscrivere la valutazione della Basilicata in un quadro nazionale, nel quale le specificità regionali si compongono in una valutazione complessiva della riforma. ↑

184. Il glossario è uniforme fra gli studi regionali della serie, così da garantire la coerenza terminologica e da agevolare il confronto fra i contesti regionali. Le definizioni hanno finalità divulgativa e non sostituiscono le trattazioni tecniche contenute nelle parti corrispondenti dello studio. ↑
185. Lo studio sulla Calabria appartiene a una serie di studi regionali costruiti secondo un telaio metodologico comune, che ne garantisce la confrontabilità. Le specificità della Calabria — l'avvio sperimentale del servizio per via amministrativa con risorse europee, la fase di uscita dal commissariamento e dal piano di rientro, il valore più elevato d'Italia della mobilità sanitaria passiva, l'inadempienza nei livelli essenziali di assistenza — sono trattate all'interno di tale telaio comune, così da coniugare la confrontabilità fra i contesti regionali con l'aderenza alla situazione particolare della regione. ↑
186. I dati riportati in questa parte provengono dal censimento permanente della popolazione dell'Istituto Nazionale di Statistica aggiornato al 2024, dal report sulla mobilità sanitaria della Fondazione Gimbe riferito al 2023, dalle rilevazioni del Ministero della Salute sulla salute mentale e dalla documentazione della programmazione sanitaria regionale, fra cui il programma operativo del piano di rientro. Le stime del disagio comune adottano una base prudenziale, riferita a circa il venti per cento della popolazione, inferiore alla quota del venti-venticinque per cento indicata dalle rilevazioni ministeriali, così da mantenere le successive proiezioni economiche su un fondamento conservativo. ↑
187. Il modello descritto in questa parte assume come punto di partenza la sperimentazione avviata dalla Giunta regionale nell'aprile 2026 e ne descrive la generalizzazione in servizio strutturale, calandola nelle condizioni organizzative reali del sistema sanitario calabrese. Le sezioni relative all'intelligenza artificiale e alla formazione richiamano, senza esaurirli, temi che costituiscono oggetto di trattazioni dedicate, in coerenza con il criterio di graduazione dell'evidenza che lo studio applica in egual misura alle affermazioni cliniche e a quelle relative all'innovazione tecnologica. ↑
188. La presente parte fonda la valutazione economica sviluppata nelle parti successive sull'efficacia clinica documentata dalla letteratura. I chiarimenti metodologici relativi al ritorno economico degli investimenti nella salute mentale e ai risparmi sanitari diretti — la corretta riconduzione delle stime alle fonti analitiche originali, entro le fasce comprese fra 2,3 e 3,0 a uno per i soli benefici economici e fra 3,3 e 5,7 a uno includendo i benefici di salute, e la natura non statisticamente significativa di alcune stime di risparmio diretto — costituiscono vincoli metodologici che lo studio applica in modo costante, così da evitare le semplificazioni divulgative e da mantenere le proiezioni su un fondamento conservativo e falsificabile. ↑
189. Tutte le stime economiche di questa parte sono espresse in bande prudenziali e articolate sui tre scenari di dimensionamento. I risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale e le ricadute economico-sociali per la collettività sono mantenuti rigorosamente distinti e non sono mai sommati in un unico saldo di bilancio; il ritorno complessivo per la collettività, presentato nel caso economico, è dato dalla loro somma ed è espressamente qualificato come valore per la collettività e non come risparmio per il bilancio. Il rapporto beneficio-costi è contenuto entro la fascia compresa fra 3,3 e 5,7 a uno, riferita alle fonti analitiche che includono i benefici di salute; non si fa uso di rapporti superiori né di semplificazioni divulgative. ↑
190. I parametri clinici del modello — le probabilità di transizione, il guadagno di salute e il risparmio per paziente — sono invarianti rispetto al contesto regionale, in quanto riflettono l'efficacia clinica documentata degli interventi; ciò che varia fra le regioni è il numero di pazienti trattati e la composizione dei risparmi e delle ricadute, che dipendono dai consumi sanitari e dalla mobilità del contesto. I risultati dell'analisi di sensibilità probabilistica — la costo-efficacia nell'88,9 per cento delle simulazioni, la dominanza nell'84,6 per cento e il beneficio netto medio di 7.815 euro per paziente, con intervallo di confidenza al 95 per cento

compreso fra circa meno 5.736 e più 21.501 euro — esprimono l'incertezza complessiva delle stime e ne attestano la robustezza, riconoscendo al tempo stesso la frazione minoritaria di simulazioni in cui l'intervento non risulta dominante né costo-efficace. ↑

191. L'analisi dell'equità assume in Calabria un rilievo preminente in ragione della combinazione di un'inadempienza nei livelli essenziali di assistenza, di una spesa per la salute mentale fra le più basse del Paese e del valore più elevato d'Italia di mobilità sanitaria passiva. La verifica che l'intervento riduca effettivamente le disuguaglianze, anziché riprodurle, richiede la misurazione disaggregata degli esiti per condizione sociale e collocazione territoriale, secondo quanto previsto dal sistema informativo e dal piano di monitoraggio; in assenza di tale verifica, l'obiettivo dell'equità rischierebbe di rimanere privo di riscontro. ↑
192. I profili giuridico, organizzativo ed etico dell'intervento presentano, nel contesto calabrese, connotati specifici derivanti dalla fase di uscita dal commissariamento e dai vincoli del piano di rientro. Il profilo giuridico è dominato dalla duplice via, amministrativa e legislativa, di istituzione del servizio e dai limiti definiti dalla sentenza costituzionale numero 241 del 2021; il profilo organizzativo dalla fase di transizione del sistema e dalle leve della centralizzazione del reclutamento e dell'orientamento digitale; il profilo etico dal dovere di non abbandono delle persone e dei territori, particolarmente pregnante in una regione segnata dalla mobilità sanitaria e dallo spopolamento delle aree interne. ↑
193. La fattibilità e la sostenibilità dell'intervento presentano, in Calabria, una difficoltà maggiore che in altre regioni, derivante dalla fase di transizione del sistema sanitario regionale e dalla natura temporanea della copertura finanziaria attuale, fondata su fondi europei. La sostenibilità del consolidamento è nondimeno conseguibile, in ragione dell'entità modesta dell'onere — inferiore allo 0,6 per cento del fondo per il costo lordo e allo 0,1 per cento per il saldo diretto — della sua compensazione attraverso i risparmi, in particolare sulla mobilità sanitaria passiva, e della gradualità dell'attuazione, a condizione che la copertura ordinaria sia programmata in sostituzione di quella europea. ↑
194. Il sistema di monitoraggio descritto in questa parte comprende una batteria dell'ordine di sessanta indicatori, articolata in otto categorie e costruita in modo da essere uniforme con quella adottata nelle altre regioni della serie. La rilevazione di una linea di base prima dell'avvio del servizio è la condizione metodologica per la valutazione controfattuale degli effetti; in Calabria, dove il sistema di rilevazione dei dati sanitari ha conosciuto una fragilità storica, la costruzione del sistema di monitoraggio assume un valore che eccede il singolo servizio, contribuendo al rafforzamento complessivo della capacità del sistema. La clausola valutativa, già prevista dalla proposta di legge regionale, costituisce il fondamento istituzionale del monitoraggio. ↑
195. L'analisi multi-criterio attribuisce all'intervento un punteggio complessivo di 78,30 e all'alternativa del non intervento un punteggio di 35,05, con un differenziale di 43,25 punti; i pesi dei criteri sono uniformi per l'intera serie regionale. Il punteggio dell'equità, il più elevato fra quelli attribuiti all'intervento, riflette la preminenza che tale dimensione assume in Calabria; il punteggio della fattibilità, il solo rispetto al quale il non intervento prevale, riflette la maggiore difficoltà attuativa del consolidamento in un sistema in fase di transizione. La raccomandazione di un percorso graduale verso lo scenario intermedio nel medio periodo e verso quello pieno a regime è condizionata al consolidamento normativo, alla sostenibilità finanziaria, alla verifica empirica e all'attenzione all'equità. ↑
196. Il glossario è uniforme fra gli studi regionali della serie, così da garantire la coerenza terminologica e da agevolare il confronto fra i contesti regionali, ed è integrato dalle voci specifiche al contesto calabrese — il commissariamento, il Fondo Sociale Europeo Plus, l'Azienda Zero, i livelli essenziali di assistenza. Le definizioni hanno finalità divulgativa e non sostituiscono le trattazioni tecniche contenute nelle parti corrispondenti dello studio. ↑

197. Posizione della Sicilia: la regione dispone di una legge dedicata e del relativo decreto attuativo, e il servizio è in fase di avvio. La legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18 (Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie), approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana e nata nel contesto dell'emergenza pandemica, prevede che il servizio sia realizzato all'interno di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, a livello dei distretti sanitari di base, da psicologi delle cure primarie, liberi professionisti in rapporto convenzionale, a sostegno e integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Alla deliberazione di Giunta n. 253 del 23 luglio 2024 e al decreto del Presidente della Regione del novembre 2024 — che disciplina la formazione degli elenchi provinciali in ciascuna Azienda, la gestione degli incarichi convenzionali, le competenze, i titoli e i criteri di valutazione — è seguito l'avvio operativo, con gli elenchi provinciali in corso di formazione. Il modello prevede due psicologi per ciascuno dei 55 distretti, con un impegno iniziale dell'ordine di 7,4 milioni di euro, e pone i costi a carico del Servizio sanitario regionale fatto salvo un ticket a carico del paziente. ↑
198. Valore dell'informazione e priorità di ricerca: l'analisi del valore atteso dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione siciliana, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle nove Aziende Sanitarie Provinciali e delle aziende ospedaliere e l'impostazione, fin dall'avvio, di un flusso uniforme dei dati di esito attraverso la relazione annuale prevista dalla legge. ↑
199. Mitigazione progressiva della lacuna: poiché il servizio è in fase di avvio, la Sicilia costruisce l'evidenza locale a partire dall'attivazione degli elenchi; impostando fin dall'inizio un flusso uniforme fra le nove Aziende, man mano che il servizio si consolida l'evidenza locale corregge progressivamente le stime importate dai benchmark, conducendo la regione da una valutazione fondata su dati esterni a una fondata in misura crescente su dati propri. ↑
200. Sintesi della modellazione: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione e consolidamento dei dati, e la condizione di regione in avvio — con una cornice normativa completa ma una base di dati ancora in formazione — impone di ancorare inizialmente la prova empirica ai benchmark, valorizzando l'opportunità di una rilevazione progettata correttamente fin dall'attivazione del servizio. ↑
201. Disagio giovanile: è una componente particolarmente rilevante, indicata come priorità dallo stesso governo regionale, con fenomeni di ansia, depressione e disturbi del comportamento alimentare tra gli adolescenti che solo in parte trovano risposta nei servizi; è più marcata nelle province più giovani, segnatamente Ragusa e Catania. ↑
202. Salute mentale connessa al lavoro e alla deprivazione: nelle aree di deprivazione urbana di Palermo e Catania, la precarietà, la disoccupazione e le condizioni socio-economiche sfavorevoli concorrono al disagio psichico; l'intercettazione precoce ha un valore particolarmente elevato in termini di salute e di equità. ↑
203. Bisogno dell'età adulta e anziana: la domanda connessa alla cronicità e alla comorbilità psicologica delle patologie croniche è più marcata nelle province interne e più anziane di Enna e Messina, a maggiore difficoltà di accesso. ↑
204. Tratto distintivo della Sicilia rispetto alle altre regioni: la combinazione di una grande regione insulare ed estesa, della condizione di regione post-legislativa in avvio — dotata di legge e decreto attuativo ma con il servizio ancora in fase di partenza — dello statuto speciale, con compartecipazione regionale al 49,11% del fabbisogno sanitario, e di una storica sotto-dotazione del sistema, aggravata dal protrarsi di un piano di rientro tuttora in corso. Il bisogno è quindi accompagnato da una cornice normativa già completa, ma da un'attuazione ancora iniziale, che la decisione è chiamata a portare a regime. ↑

205. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche significativi: rapportando alla popolazione siciliana il dato nazionale, dell'ordine di alcune decine di migliaia l'anno, indice di una pressione sul sistema acuto che un primo livello territoriale pienamente strutturato potrebbe in parte contenere a monte. ↑
206. Offerta territoriale: la Sicilia ha istituito il servizio di psicologia delle cure primarie con la legge regionale 18 del 2023 e ne ha disciplinato l'attuazione con la deliberazione di Giunta n. 253 del 2024 e con il decreto del Presidente della Regione del novembre 2024, che regola la formazione degli elenchi provinciali in ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale. Il servizio è in fase di avvio, con gli elenchi in formazione; il modello prevede due psicologi per ciascuno dei 55 distretti — liberi professionisti in rapporto convenzionale — con costi a carico del Servizio sanitario regionale fatto salvo un ticket a carico del paziente, un impegno iniziale dell'ordine di 7,4 milioni di euro e l'assenza, allo stato, di un contratto collettivo nazionale di riferimento. ↑
207. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 1.030 psicologi nello scenario espansivo (e dell'ordine di 520 e 780 negli scenari conservativo e di base). L'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, che ha accompagnato l'elaborazione e l'attuazione della legge, ne sostiene la piena operatività e l'estensione a regime. ↑
208. Copertura attuale del fabbisogno iniziale: la dotazione prevista, dell'ordine di 110 psicologi corrispondente ai due per ciascuno dei 55 distretti, costituisce il nucleo di avvio, sufficiente ad avviare il servizio ma non a coprirne il fabbisogno a regime. La decisione, di conseguenza, non verte sull'istituire il servizio, già istituito per legge, né sull'emanarne il decreto, già emanato, ma sul condurlo dall'avvio al regime, stabilizzarne il finanziamento e dimensionarlo verso la copertura piena. ↑
209. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante nella Sicilia si gioca su due assi. Il primo è interno alle aree metropolitane di Palermo e Catania, fra i quartieri meglio serviti e le periferie con sacche di deprivazione socio-economica. Il secondo separa le aree metropolitane e costiere dalle province interne di Enna e Caltanissetta, più anziane, a minore densità e penalizzate dalla condizione insulare. La telepsicologia assistita è lo strumento per avvicinare l'offerta alle aree interne e insulari, dove la presenza di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio. ↑
210. Finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 10-11 miliardi di euro; in quanto regione a statuto speciale, la Sicilia partecipa al finanziamento sanitario nella misura del 49,11% del proprio fabbisogno, e riceve dallo Stato risorse inferiori alla spesa effettivamente sostenuta. La regione resta sottoposta a piano di rientro e presenta una spesa pro-capite fra le più basse del Paese; tale storica sotto-dotazione lascia tuttavia margini di consumo improprio ampi da recuperare. ↑
211. Mobilità sanitaria: la Sicilia presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, dell'ordine di duecentocinquanta milioni di euro l'anno (terzo-quarto valore negativo del Paese). La fuga si concentra però nei ricoveri ospedalieri e nelle prestazioni ad alta complessità, segnatamente chirurgiche, e non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. ↑
212. Cornice normativa e programmatica: la Sicilia ha istituito il servizio con la legge regionale 18 del 2023, attuata dalla deliberazione di Giunta n. 253 del 2024 e dal decreto del Presidente della Regione del novembre 2024. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera. A differenza del Lazio, la Sicilia non è in fase pre-legislativa, ma di avvio di un servizio già istituito e di cui è già stato emanato il decreto attuativo; rispetto alla Campania, prima in Italia con la legge 35 del 2020, la Sicilia si colloca nell'onda successiva delle regioni che hanno legiferato in materia, entro i vincoli propri dello statuto speciale e del piano di rientro. ↑

213. Popolazione residente in Sicilia 4.787.390 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa l'8,1% della popolazione nazionale, in lieve calo rispetto all'anno precedente per effetto del saldo naturale e migratorio interno negativi. Le province di Palermo e Catania raccolgono insieme circa il 47,4% dei residenti — Palermo è l'unico comune a superare il mezzo milione di abitanti, con 630.427 residenti — seguite da Messina con circa il 12,5%. La struttura per età presenta un'età media di 45,7 anni, con le province di Ragusa e Catania più giovani (44,5 e 44,8 anni) e quelle di Messina ed Enna più anziane (47,2 e 47,0 anni); la componente straniera, intorno al 4,3%, è nettamente inferiore alla media nazionale. ↑
214. ↑
215. Popolazione residente in Sicilia 4.787.390 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa l'8,1% della popolazione nazionale, in lieve calo rispetto all'anno precedente per effetto del saldo naturale e migratorio interno negativi. Le province di Palermo e Catania raccolgono insieme circa il 47,4% dei residenti — Palermo è l'unico comune a superare il mezzo milione di abitanti, con 630.427 residenti — seguite da Messina con circa il 12,5%. La struttura per età presenta un'età media di 45,7 anni, con le province di Ragusa e Catania più giovani (44,5 e 44,8 anni) e quelle di Messina ed Enna più anziane (47,2 e 47,0 anni); la componente straniera, intorno al 4,3%, è nettamente inferiore alla media nazionale. Equità come dominio della valutazione: l'analisi distributiva non è un'appendice, ma un dominio proprio dell'HTA, poiché un intervento può essere efficiente nel complesso e tuttavia accrescere le disuguaglianze, o al contrario ridurle; lo studio impiega l'analisi di costo-efficacia distributiva per misurarne l'effetto sui divari, oltre che sull'efficienza. ↑
216. Gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori; la circostanza assume particolare rilievo in una regione con una spesa pro-capite fra le più basse del Paese. ↑
217. Barriere all'accesso: il ricorso al sostegno psicologico è ostacolato da barriere economiche, geografiche e culturali, oltre che dallo stigma. Nella Sicilia la componente straniera è contenuta, intorno al 4,3%, sicché la barriera linguistica e culturale, pur presente nelle aree di maggiore insediamento, è meno centrale che in altre regioni; più rilevante è la barriera generazionale, poiché il disagio giovanile trova negli adolescenti e nei giovani adulti una fascia spesso restia a rivolgersi ai servizi. Un elemento proprio del modello siciliano va segnalato con franchezza: la previsione di un ticket a carico del paziente reintroduce una barriera economica, che le esenzioni per le fasce protette attenuano ma non eliminano, e che va calibrata con attenzione perché non vanifichi la funzione di equità del servizio. ↑
218. Doppio asse della disuguaglianza nella Sicilia: la regione presenta due assi distinti, cui si aggiunge una dimensione generazionale. Il primo asse è interno alle aree metropolitane di Palermo e Catania, fra i quartieri meglio serviti e le periferie con sacche di deprivazione socio-economica. Il secondo separa le aree metropolitane e costiere dalle province interne — Enna e Caltanissetta in particolare — più anziane, a minore densità, penalizzate dalla condizione insulare e con servizi più radi. A questi si somma il disagio giovanile, indicato come priorità dal governo regionale e più marcato nelle province più giovani. ↑
219. Primo asse, la periferia metropolitana di Palermo e Catania: nelle due aree urbane maggiori, accanto a quartieri meglio serviti, si estendono periferie popolate con sacche di deprivazione socio-economica, dove la difficoltà di accesso ai servizi e la minore disponibilità di offerta privata accrescono il bisogno non intercettato. ↑
220. Secondo asse, le province interne e insulari: Enna e Caltanissetta, e le aree interne dell'isola, presentano una popolazione più anziana, a minore densità e con tendenze allo spopolamento, dove la rarefazione dei servizi, le distanze e la condizione insulare rendono l'accesso al sostegno psicologico particolarmente difficoltoso. ↑

221. Effetto del servizio sull'equità: la prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano parte delle barriere all'accesso e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso; nel modello siciliano, tuttavia, il servizio non è integralmente gratuito ma soggetto a ticket, sicché il meccanismo pro-equità opera pienamente solo se la compartecipazione è contenuta e le esenzioni efficaci, condizione affinché un servizio universale riduca, anziché accrescere, il divario. ↑
222. Telepsicologia assistita: nella Sicilia è lo strumento per avvicinare l'offerta alle province interne di Enna e Caltanissetta e alle periferie di Palermo e Catania, dove le distanze, la condizione insulare e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; concepita come complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, essa estende la copertura proprio nelle aree a maggiore difficoltà di accesso. ↑
223. Competenza generazionale e culturale: data la quota straniera contenuta, la competenza culturale e la mediazione linguistica restano necessarie nelle aree di maggiore insediamento ma sono meno centrali che altrove; più dirimente è la competenza nell'intercettare il disagio giovanile, affinché il servizio raggiunga adolescenti e giovani adulti, fascia a elevato bisogno e a basso ricorso spontaneo, in coerenza con la priorità che il governo regionale ha assegnato alla salute psicologica dei giovani. ↑
224. Costo-efficacia distributiva: l'analisi indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, in quanto i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto; l'intervento è quindi favorevole all'equità, oltre che costo-efficace, a condizione che il ticket sia calibrato in modo da non escludere le fasce a minore capacità di spesa. ↑
225. Modulazione territoriale della copertura: per realizzare il potenziale di equità, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle periferie di Palermo e Catania e alle province interne di Enna e Caltanissetta; un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un'allocazione ponderata per il bisogno li riduce. La fase di avvio, con gli elenchi provinciali ancora in formazione, offre l'occasione di orientare fin dall'inizio l'allocazione secondo criteri di equità. ↑
226. Mobilità e equità: nella Sicilia il canale della mobilità è, per questo intervento, una leva di equità solo modesta, poiché la fuga — pur fra le più elevate d'Italia — riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica e non la domanda psicologica territoriale; l'equità si gioca quindi prevalentemente sull'accesso interno, fra centro e periferie delle aree urbane e fra aree metropolitane e province interne e insulari. ↑
227. Rischio di iniquità inversa: se l'attivazione del servizio privilegiasse, per facilità organizzativa, le aree già meglio servite, l'effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell'allocazione delle sedi e degli incarichi, fin dalla formazione degli elenchi provinciali, e con una calibrazione del ticket che non penalizzi le aree e le fasce a minore capacità di spesa. ↑
228. Sintesi dell'equità: l'intervento è favorevole all'equità su entrambi gli assi del divario siciliano e sulla dimensione generazionale, a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno, che siano garantite la telepsicologia per le periferie e le aree interne e insulari e l'attenzione al disagio giovanile, e che il ticket sia calibrato con esenzioni efficaci; la raccomandazione è di orientare fin dall'avvio, nella formazione degli elenchi provinciali, un'allocazione pro-equità che dia di più dove il bisogno è maggiore. ↑
229. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; il servizio in fase di avvio, con dimensionamento iniziale, come comparatore. ↑
230. ↑

231. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; il servizio in fase di avvio, con dimensionamento iniziale, come comparatore. Metodo della revisione: la sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche (PRISMA 2020) e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE; sono considerati studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. ↑
232. Studio fondativo del modello collaborativo (IMPACT), pubblicato su JAMA nel 2002: circa il 50% dei pazienti trattati ha conseguito una riduzione di almeno il 50% dei sintomi a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. ↑
233. Meta-analisi su cinquantasette studi controllati (2012): l'integrazione della cura ha prodotto un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard rispetto alla cura usuale. ↑
234. Revisione di quarantadue implementazioni del modello (2024): riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 43% dell'ansia a sei mesi, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. ↑
235. Programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies), dati reali 2023-2024: tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile del 67,8% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su una scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno. ↑
236. Meta-analisi sulle cure integrate: coefficiente standardizzato dell'ordine di -0,11 sui sintomi depressivi, di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante quando applicato a una popolazione ampia. ↑
237. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. ↑
238. Cautela metodologica rilevante: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi (l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero); il valore economico del modello poggia in misura preponderante sui ritorni sociali, non sui risparmi sanitari diretti. Questa cautela è coerente con il profilo del caso economico campano, fondato anch'esso sulle ricadute sociali. ↑
239. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. ↑
240. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. ↑
241. ↑
242. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. Tre profili intrecciati: la fattibilità dell'intervento dipende dal presidio congiunto di un profilo giuridico (la competenza e la forma dell'atto), di un profilo organizzativo (l'assetto e la governance dell'istituzione) e di un profilo etico (le tutele a garanzia dei pazienti); lo studio li tratta unitariamente, poiché una debolezza in uno solo di essi comprometterebbe l'intera operazione. ↑
243. Profilo giuridico e riparto di competenza: la materia si colloca nella competenza legislativa concorrente in tema di tutela della salute. La sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — pronuncia fondativa per l'intera materia, originata dal giudizio sulla legge campana, di cui ha riconosciuto la legittimità — ha

delimitato lo spazio della disciplina regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Entro questa cornice la Sicilia, regione a statuto speciale, ha esercitato il titolo a istituire il servizio con la legge regionale 18 del 2023, in forma coordinata con la cornice nazionale. ↑

244. Stato legislativo della Sicilia: a differenza del Lazio, ancora privo di legge, la Sicilia dispone già della legge regionale 18 del 2023, della deliberazione di Giunta n. 253 del 2024 e del decreto attuativo del novembre 2024, in forza dei quali il servizio è in fase di avvio. La decisione giuridica rilevante non è quindi l'approvazione della legge istitutiva, già compiuta, né l'emanazione del decreto, già emanato, ma il passaggio dall'avvio al regime: la stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro e il perfezionamento dell'inquadramento convenzionale, nel coordinamento con il testo unico nazionale in discussione. ↑
245. Inquadramento del rapporto di lavoro: la legge regionale 18 del 2023 e il decreto attuativo hanno adottato il rapporto convenzionale su base libero-professionale, con iscrizione a un elenco provinciale presso ciascuna Azienda secondo titoli e criteri di valutazione definiti, per analogia con la medicina generale e la pediatria di libera scelta, e con un ticket a carico del paziente. Tale forma assicura flessibilità e prossimità, ma sconta l'assenza di un contratto collettivo nazionale di riferimento: la sua definizione, attesa dal testo unico nazionale, è condizione di stabilità e di tutela della continuità del rapporto. ↑
246. Livelli essenziali di assistenza e finanziamento: la psicologia delle cure primarie non è ancora esplicitamente ricompresa nei livelli essenziali di assistenza nazionali. In quanto regione a statuto speciale, la Sicilia partecipa al finanziamento sanitario nella misura del 49,11% del proprio fabbisogno e resta sottoposta a piano di rientro; la legge ha disposto un impegno iniziale dell'ordine di 7,4 milioni di euro, e la strutturazione a regime richiede di reperire un finanziamento regionale stabile entro tali vincoli, mentre un futuro riconoscimento nei livelli essenziali rafforzerebbe ulteriormente la stabilità. ↑
247. Cornice degli standard territoriali: il Decreto Ministeriale 77 del 2022 definisce gli standard dell'assistenza territoriale e individua nelle Case della Comunità il fulcro dell'integrazione delle cure primarie; il servizio di psicologia delle cure primarie vi si inserisce coerentemente, come uno dei livelli di risposta al bisogno della popolazione. ↑
248. Rapporto con i servizi specialistici: il servizio di psicologia delle cure primarie precede e alleggerisce i Centri di Salute Mentale, intercettando e trattando i quadri lievi e moderati e indirizzando a essi i casi che richiedono cure specialistiche; l'integrazione, e non la sovrapposizione, è il principio che ne governa il rapporto con la rete esistente. ↑
249. Assetto organizzativo: la strutturazione del servizio nella Sicilia si misura con un sistema esteso e insulare — nove Aziende Sanitarie Provinciali, numerose aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e ad alta specializzazione — e con l'assenza di un'azienda regionale unica, sicché il coordinamento è in capo all'Assessorato regionale della Salute; garantire l'omogeneità attuativa fra le nove Aziende, su un territorio ampio e frammentato, è la sfida organizzativa centrale. ↑
250. Governance della strutturazione: il consolidamento del servizio richiede una regia regionale che coordini le nove Aziende Sanitarie Provinciali, le aziende ospedaliere, l'Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei; tale regia è in capo all'Assessorato regionale della Salute, attraverso il Dipartimento per la pianificazione strategica e il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, cui spetta definire indirizzi operativi uniformi e impostare il sistema di monitoraggio comune, fondato sulla relazione annuale prevista dalla legge. ↑
251. Ruolo dell'Ordine professionale: l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, che ha accompagnato l'elaborazione e l'attuazione della legge, concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione e alla vigilanza deontologica; la sua collaborazione è condizione della qualità e dell'appropriatezza del servizio. ↑

252. Profilo etico, tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici; è una cautela che presidia l'intervento presso le fasce più fragili. [↑](#)
253. Consenso e riservatezza: l'intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un'informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell'efficacia stessa del sostegno psicologico. [↑](#)
254. Strumenti di intelligenza artificiale e quadro europeo: gli strumenti digitali eventualmente impiegati sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. [↑](#)
255. Protezione dei dati personali: il trattamento è conforme alla normativa vigente, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. [↑](#)
256. Responsabilità professionale: il professionista resta pienamente responsabile delle decisioni cliniche, e gli strumenti di supporto, anche quelli basati sull'intelligenza artificiale, forniscono un ausilio non vincolante; la chiarezza sull'imputazione della responsabilità è condizione di un impiego sicuro e appropriato della tecnologia. [↑](#)
257. Sintesi dei profili: i tre profili — giuridico, organizzativo ed etico — sono presidiati, e la condizione abilitante dell'intervento non è, per la Sicilia, l'approvazione della legge, già in vigore, né l'emanazione del decreto attuativo, già emanato, ma il passaggio dall'avvio al regime: la stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro e dello statuto speciale e la formazione degli elenchi provinciali fra le nove Aziende; è questo il passaggio da cui dipende la piena operatività del servizio, che il coordinamento con il futuro testo unico nazionale potrà rafforzare. [↑](#)
258. Benchmark statunitense (Collaborative Care): modello a équipe integrata, validato da oltre novanta studi controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri. [↑](#)
259. Esperienze italiane: il quadro nazionale comprende i servizi avviati nelle regioni dotate di legge — fra cui la Campania, prima a istituire e attivare il servizio — e le esperienze pilota fondate su campioni limitati e letteratura grigia. La Sicilia, che ha istituito il servizio con la legge regionale 18 del 2023 e ne ha emanato il decreto attuativo, si colloca in questo quadro come regione in fase di avvio: non dispone ancora di una base di dati di esito propri, che si formerà man mano che gli elenchi provinciali si completano e affluiscono le relazioni annuali previste dalla legge. [↑](#)
260. Trasferibilità: i risultati internazionali provengono da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale; la loro trasposizione richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche. [↑](#)
261. Evidenza locale siciliana: poiché il servizio è in fase di avvio, l'evidenza locale è allo stato prevalentemente prospettica. Lo studio poggia, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, e la base di dati propri si costituirà progressivamente attraverso la relazione annuale che la legge pone a carico degli psicologi delle cure primarie: la fase di avvio consente di progettare fin dall'inizio una rilevazione uniforme fra le nove Aziende, presupposto di un'evidenza locale solida da consolidare man mano che il servizio raggiunge il regime. [↑](#)
262. Condizioni siciliane per la trasferibilità e la valutazione: la Sicilia dispone della cornice normativa completa, dell'infrastruttura informatica sanitaria regionale e della rete delle Case della Comunità in costruzione; la condizione propria della regione, in fase di avvio, è di dover costruire l'evidenza locale a partire dai

benchmark internazionali, impostando la rilevazione in forma uniforme fra le nove Aziende fin dalla formazione degli elenchi, così da generare dati propri solidi man mano che il servizio raggiunge il regime. ↑

263. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative: il rapporto di 4:1 spesso citato e l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio sono semplificazioni a fini divulgativi; lo stesso vale per il rapporto di 2,5:1 talvolta richiamato in ambito regionale. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costo complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8:1-5,5:1. ↑
264. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. Il profilo finanziario della Sicilia presenta un vincolo proprio: regione a statuto speciale, essa compartecipa al finanziamento sanitario nella misura del 49,11% del proprio fabbisogno, e resta tuttora sottoposta a piano di rientro, con una spesa pro-capite fra le più basse del Paese. Sul versante della mobilità sanitaria, presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, ma la fuga si concentra nei ricoveri ospedalieri e nelle prestazioni ad alta complessità, non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. Ne consegue un saldo diretto lievemente negativo ma prossimo al pareggio — meno sfavorevole di quanto il vincolo di bilancio lascerebbe temere, poiché il sistema siciliano, a lungo sotto-finanziato, presenta un consumo improprio più ampio da recuperare — cui il ticket a carico del paziente apporta un'ulteriore, lieve attenuazione, mentre il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi. ↑
265. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (8,1%) e non estratti dai conti regionali certificati delle nove Aziende Sanitarie Provinciali e delle aziende ospedaliere: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare prima della presentazione esterna. Poiché il servizio è in fase di avvio, la Sicilia non dispone ancora della base di dati operativi propri di cui gode una regione a servizio pienamente attivo; lo studio poggia perciò, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, e la relazione annuale che la legge già prevede a carico degli psicologi delle cure primarie costituirà la fonte primaria da consolidare man mano che gli elenchi si completano. ↑
266. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
267. Valutazione controfattuale d'impatto: poiché il servizio è in avvio e gli elenchi provinciali si completano in tempi differenziati tra le nove Aziende Sanitarie Provinciali, il disegno può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le Aziende e i loro distretti sono impiegati a fini valutativi. L'effetto causale è stimato con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico; la fase di avvio consente di rilevare una linea di base prima della piena operatività, sebbene la Sicilia non disponga ancora dei dati operativi propri di una regione a servizio già consolidato. ↑
268. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione, nove Aziende Sanitarie Provinciali (Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani), aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e ad alta specializzazione, Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e atenei. La Sicilia non dispone di un'azienda regionale unica né di un'agenzia di coordinamento: il coordinamento è in capo all'Assessorato regionale della Salute, attraverso il Dipartimento per la pianificazione strategica e il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. La sfida del governo non è quindi istituire il servizio, né emanarne il decreto attuativo, ma condurlo dall'avvio al regime e dimensionarlo, garantendo l'omogeneità attuativa fra le nove Aziende in un sistema esteso e insulare. ↑

269. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce l'infrastruttura per la raccolta uniforme. ↑
270. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
271. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. ↑
272. ↑
273. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. I cinque casi della decisione di investimento pubblico: lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile; la convergenza dei cinque casi è condizione della solidità della decisione. ↑
274. Caso strategico: l'istituzione del servizio è coerente con la cornice nazionale degli standard territoriali, con la centralità delle Case della Comunità e con la programmazione regionale per la salute mentale; nella Sicilia essa presenta una coerenza ulteriore, poiché porta a regime il modello che la regione ha già istituito per legge e di cui ha già emanato il decreto attuativo, dando piena operatività a un servizio in fase di avvio. ↑
275. Caso economico: rinvia ai risultati della valutazione economica — un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,9-5,5 a uno e una dominanza per paziente con elevata probabilità — nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di modesto disavanzo e un caso sociale fortemente positivo. ↑
276. Caso commerciale: il modello del rapporto convenzionale su base libero-professionale è già disciplinato e si avvale, nella Sicilia, di un ampio bacino professionale alimentato dagli atenei siciliani — Palermo, Catania, Messina e Kore di Enna; la disponibilità di psicologi qualificati, selezionati attraverso gli elenchi provinciali secondo titoli e criteri definiti dal decreto, non costituisce un vincolo all'estensione. ↑
277. Caso finanziario: il costo del servizio a regime — dell'ordine di 29, 43 e 57 milioni di euro nei tre scenari, pari allo 0,3-0,5% del finanziamento sanitario regionale — è contenuto, ma va reperito entro un vincolo proprio: la Sicilia, regione a statuto speciale, partecipa al finanziamento nella misura del 49,11% del fabbisogno e resta sottoposta a piano di rientro. La legge ha disposto un impegno iniziale dell'ordine di 7,4 milioni di euro, e la sfida finanziaria è reperire un finanziamento regionale stabile entro tali vincoli. ↑
278. Caso gestionale: la realizzabilità dipende da una regia regionale che, in assenza di un'azienda unica, coordina le nove Aziende Sanitarie Provinciali, le aziende ospedaliere e ad alta specializzazione, l'Ordine professionale, la medicina generale e la pediatria di libera scelta e gli atenei; tale regia è in capo all'Assessorato regionale della Salute, attraverso i suoi Dipartimenti, cui spetta definire indirizzi uniformi e impostare il monitoraggio comune. ↑
279. Dimensionamento a partire dal nucleo di avvio: a differenza del Lazio, che deve dimensionare il servizio da zero, la Sicilia muove dal nucleo di avvio previsto dalla legge, dell'ordine di 110 psicologi corrispondente ai due per ciascuno dei 55 distretti, e lo estende verso un fabbisogno a regime dell'ordine di 1.030 psicologi

nello scenario espansivo; l'estensione procede per gradi attraverso gli scenari conservativo, di base ed espansivo, man mano che gli elenchi provinciali si completano. ↑

280. Fasi di attuazione: poiché il servizio è in fase di avvio, l'attuazione si articola in una fase di formazione degli elenchi provinciali e di avvio operativo; una fase di estensione, nella quale la copertura si amplia progressivamente fra le nove Aziende; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato al fabbisogno. La progressione differenziata della formazione degli elenchi fra le Aziende coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F. ↑
281. Reclutamento e formazione: l'avvio a regime richiede il reclutamento e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino professionale, i titoli e i criteri di valutazione già definiti dal decreto e gli atenei siciliani costituiscono una base favorevole, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze. ↑
282. Cronoprogramma: l'attuazione si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; a differenza del Lazio, l'estensione non è subordinata all'approvazione di una legge — già in vigore — né all'emanazione del decreto — già emanato — ma alla formazione degli elenchi provinciali e alla stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro. ↑
283. Sostenibilità finanziaria: la leva della sostenibilità, nella Sicilia, è la stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli dello statuto speciale e del piano di rientro, a valere sull'impegno iniziale già disposto dalla legge, e il dimensionamento progressivo del servizio; il sistema, storicamente sotto-finanziato, presenta margini di consumo improprio ampi da recuperare, mentre l'eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe in futuro la stabilità. ↑
284. Sostenibilità organizzativa: la sfida è garantire l'omogeneità attuativa fra le nove Aziende Sanitarie Provinciali in un sistema esteso e insulare privo di un'azienda regionale unica; la sostenibilità organizzativa dipende dalla forza della regia dell'Assessorato regionale, dal ruolo dei suoi Dipartimenti e dalla chiarezza degli indirizzi operativi. ↑
285. Monitoraggio dell'attuazione: l'avanzamento è seguito mediante indicatori di processo — sedi attivate, incarichi conferiti, prese in carico — raccolti attraverso la relazione annuale prevista dalla legge, che la fase di avvio consente di impostare fin dall'inizio in forma uniforme fra le nove Aziende. ↑
286. Rischi principali dell'attuazione: la disomogeneità attuativa fra le nove Aziende in un sistema insulare; la difficoltà di coordinamento in assenza di un'azienda unica; il vincolo del piano di rientro e dello statuto speciale sulla disponibilità di un finanziamento stabile; e l'esigenza di calibrare il ticket perché non ostacoli l'accesso, cui si aggiunge l'assenza di un contratto collettivo nazionale. ↑
287. Mitigazioni: i rischi sono fronteggiati con una regia regionale forte e indirizzi operativi uniformi, con la progressione differenziata della formazione degli elenchi fra le Aziende che consente un apprendimento progressivo, e con un'allocazione pro-equità che orienta l'estensione verso le aree a maggiore bisogno e con un ticket calibrato; la stabilizzazione del finanziamento e il sostegno dell'Ordine professionale concorrono a ridurre l'incertezza. ↑
288. Sintesi dell'attuazione: l'intervento è attuabile e sostenibile, e la leva propria della Sicilia è la formazione degli elenchi provinciali e la stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro; la regione muove da un nucleo di avvio già previsto, da un bacino professionale ampio e da una cornice normativa completa, sicché le condizioni di fattibilità sono complessivamente favorevoli, pur entro un vincolo di bilancio più stretto che altrove. ↑
289. Struttura per età: l'età media è dell'ordine di 45,7 anni, in lieve crescita. La distribuzione interna è disomogenea: le province di Ragusa e Catania sono le più giovani (età media dell'ordine di 44,5 e 44,8 anni), mentre Messina ed Enna sono le più anziane (47,2 e 47,0 anni). La componente straniera concorre al

ringiovanimento della popolazione. ↑

290. Componente straniera dell'ordine del 4,3% dei residenti (206.753 persone), nettamente inferiore alla media nazionale e fra le più contenute fra le regioni esaminate; ciò rende la dimensione della competenza culturale meno centrale che in altre regioni, pur restando rilevante nelle aree di maggiore insediamento. ↑
291. Distribuzione territoriale concentrata sui due poli maggiori: le province di Palermo e Catania raccolgono insieme circa il 47,4% dei residenti; Palermo è l'unico comune a superare il mezzo milione di abitanti, con 630.427 residenti, più del doppio di Catania (298.680). Segue la provincia di Messina, con circa il 12,5%; le restanti sei province raccolgono circa il 40,2%. ↑
292. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato le aree metropolitane di Palermo e Catania, densamente popolate e con estese aree di deprivazione socio-economica; dall'altro le province interne e meno popolate di Enna e Caltanissetta, più anziane e a minore densità, dove la rarefazione dei servizi, le distanze e la condizione insulare acuiscono le difficoltà di accesso. ↑
293. ↑
294. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato le aree metropolitane di Palermo e Catania, densamente popolate e con estese aree di deprivazione socio-economica; dall'altro le province interne e meno popolate di Enna e Caltanissetta, più anziane e a minore densità, dove la rarefazione dei servizi, le distanze e la condizione insulare acuiscono le difficoltà di accesso. Definizione: lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Nella Sicilia tale definizione è già recepita nella legge regionale 18 del 2023 e nel relativo decreto attuativo. ↑
295. ↑
296. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato le aree metropolitane di Palermo e Catania, densamente popolate e con estese aree di deprivazione socio-economica; dall'altro le province interne e meno popolate di Enna e Caltanissetta, più anziane e a minore densità, dove la rarefazione dei servizi, le distanze e la condizione insulare acuiscono le difficoltà di accesso. Definizione: lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Nella Sicilia tale definizione è già recepita nella legge regionale 18 del 2023 e nel relativo decreto attuativo. Impianto della valutazione economica: lo studio impiega congiuntamente l'analisi costo-utilità, che rapporta il costo agli anni di vita ponderati per la qualità; l'analisi di impatto sul bilancio, che misura la sostenibilità finanziaria esercizio per esercizio; e l'analisi del ritorno sociale, che valuta il valore generato per la collettività. La doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società distingue rigorosamente i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali più ampie. ↑
297. Costo del servizio: assumendo un costo medio annuo per incarico dell'ordine di 55.000 euro, comprensivo degli oneri, i tre scenari di copertura corrispondono a un costo annuo a regime dell'ordine di 29 milioni di euro nello scenario conservativo (circa 520 psicologi), 43 milioni nello scenario di base (circa 780) e 57 milioni nello scenario espansivo (circa 1.030), nel modello del rapporto convenzionale su base libero-professionale già adottato dalla legge regionale. ↑
298. Scenari di copertura del fabbisogno: lo scenario conservativo, di base ed espansivo rappresentano gradi crescenti di copertura della popolazione con disagio comune, verso la copertura piena del fabbisogno. La dotazione iniziale prevista, dell'ordine di 110 psicologi corrispondente ai due per ciascuno dei 55 distretti, costituisce il nucleo di avvio, inferiore allo stesso scenario conservativo; gli scenari qui considerati rappresentano il regime e non la prima fase di avvio. ↑

299. Risparmio diretto sugli accessi impropri al pronto soccorso: dell'ordine di 4, 6 e 9 milioni di euro l'anno nei tre scenari, per effetto della riduzione degli accessi per cause psichiatriche e somatoformi intercettabili a livello territoriale, particolarmente rilevanti in un sistema storicamente sotto-dotato. ↑
300. Risparmio diretto sulla spesa farmaceutica: dell'ordine di 4, 7 e 10 milioni di euro l'anno, per effetto della riduzione delle prescrizioni inappropriate di antidepressivi e ansiolitici nei quadri lievi, in favore dell'intervento psicologico. ↑
301. Risparmio diretto su ricoveri e specialistica: dell'ordine di 11, 17 e 29 milioni di euro l'anno, per effetto della riduzione di ricoveri evitabili, consulti specialistici ripetuti e accertamenti inappropriate connessi a disagio non riconosciuto; il margine di recupero è ampio in ragione della sotto-dotazione storica del sistema. ↑
302. Recupero della mobilità sanitaria: per la Sicilia il contributo è modesto, dell'ordine di 4, 6 e 8 milioni di euro l'anno nei tre scenari, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. La regione presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, ma la fuga si concentra nei ricoveri ospedalieri e nelle prestazioni chirurgiche ad alta complessità, non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché questo canale — che per altri interventi sarebbe una leva centrale di una regione debitrice del Mezzogiorno — contribuisce qui solo per la quota di domanda impropria, prevalentemente somatoforme, che un primo livello territoriale può trattenere. ↑
303. ↑
304. Recupero della mobilità sanitaria: per la Sicilia il contributo è modesto, dell'ordine di 4, 6 e 8 milioni di euro l'anno nei tre scenari, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. La regione presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, ma la fuga si concentra nei ricoveri ospedalieri e nelle prestazioni chirurgiche ad alta complessità, non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché questo canale — che per altri interventi sarebbe una leva centrale di una regione debitrice del Mezzogiorno — contribuisce qui solo per la quota di domanda impropria, prevalentemente somatoforme, che un primo livello territoriale può trattenere. Finalità del monitoraggio e della valutazione ex post: rendere conto dell'impiego delle risorse, apprendere dall'esperienza e correggere il corso dell'attuazione; la valutazione non è un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l'istituzione del servizio si traduce in apprendimento istituzionale, ed è ancorata a una clausola valutativa. ↑
305. Impianto secondo i tre livelli di struttura, processo ed esito: la valutazione distingue le condizioni e le risorse del servizio (struttura), le attività e il loro svolgimento (processo) e i risultati conseguiti (esito), in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti. ↑
306. Disegno controfattuale su servizio in avvio: poiché nella Sicilia il servizio è in fase di avvio e gli elenchi provinciali si completano in tempi differenziati, la valutazione d'impatto può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le nove Aziende Sanitarie Provinciali e i loro distretti sono impiegati a fini valutativi; la fase di avvio offre il vantaggio peculiare di poter rilevare una linea di base anteriore alla piena operatività, condizione che le regioni a servizio già consolidato non possiedono. ↑
307. Linea di base dalla progressione differenziata: poiché il servizio è in avvio, la Sicilia può rilevare una linea di base prima dell'attivazione, e il diverso grado di formazione degli elenchi fra le nove Aziende consente di costruire termini di confronto interni; la rilevazione, progettata fin dall'inizio in forma uniforme, fonda una stima dell'effetto su dati propri man mano che il servizio si attiva. ↑
308. Metodi di stima dell'effetto: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze, che confronta l'evoluzione delle aree già attivate con quella delle aree non ancora attivate, e con il metodo del controllo sintetico, che costruisce un termine di confronto a partire dai dati osservati; la progressione differenziata

della formazione degli elenchi fra le nove Aziende fornisce la variazione necessaria all'identificazione. ↑

309. Indicatori di struttura: numero di sedi attivate nelle Case della Comunità, incarichi conferiti, ore di servizio disponibili, dotazione tecnologica e copertura territoriale rispetto al fabbisogno; misurano la capacità effettivamente installata. ↑
310. Indicatori di processo: prese in carico, tempo di attesa al primo colloquio, numero di colloqui per persona, tasso di invio appropriato ai servizi specialistici e aderenza ai percorsi clinici; misurano il funzionamento del servizio. ↑
311. Indicatori di esito clinico: quota di miglioramento e tasso di recupero, misurati con gli strumenti validati nei soli punteggi complessivi, e remissione dei quadri trattati; misurano il beneficio diretto per le persone. ↑
312. Indicatori di esito di sistema: accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche, prescrizioni di psicofarmaci nei quadri lievi, ricoveri evitabili e consulti specialistici impropri; misurano l'effetto dell'intervento sul resto del sistema. ↑
313. Indicatori economici: costo del servizio, risparmi diretti per canale, ricadute economico-sociali e rapporto beneficio-costi, calcolati su dati reali man mano disponibili; consentono di verificare ex post le stime dello studio e di sostituire progressivamente i valori ricostruiti con quelli effettivi. ↑
314. Indicatori di equità: copertura e accesso disaggregati per area — centro e periferie napoletane, province interne di Avellino e Benevento — e per fasce di età, con attenzione al disagio giovanile particolarmente rilevante in una regione giovane; verificano che il servizio riduca i divari anziché accrescerli, coerentemente con l'allocazione pro-equità raccomandata. ↑
315. Indicatori di qualità: soddisfazione degli utenti, appropriatezza delle prese in carico e degli invii, continuità del rapporto e qualità percepita della relazione; integrano la misurazione degli esiti con la dimensione dell'esperienza. ↑
316. Indicatori di mobilità: per la Sicilia sono monitorati ma costituiscono un esito atteso solo modesto, poiché la fuga — pur fra le più elevate d'Italia — riguarda l'alta complessità ospedaliera e chirurgica e non la domanda psicologica territoriale; la loro rilevazione serve a documentare la sola frazione territorialmente intercettabile, non un effetto principale. ↑
317. Batteria complessiva di indicatori: l'insieme è organizzato in otto categorie — struttura, processo, esito clinico, esito di sistema, economici, equità, qualità e mobilità — per un totale dell'ordine di cinquantotto indicatori, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile della rilevazione; la batteria è comune alla serie e adattata al contesto siciliano. ↑
318. Cruscotto regionale di monitoraggio: gli indicatori confluiscono in un cruscotto aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; in assenza di un'azienda regionale unica, la titolarità del cruscotto è in capo all'Assessorato regionale della Salute e ai suoi Dipartimenti, che ne assicurano l'alimentazione uniforme da parte delle nove Aziende. ↑
319. Clausola valutativa: lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa; a differenza del Lazio, che deve inserirla nella futura legge, la Sicilia dispone già di una previsione di relazione annuale a carico degli psicologi delle cure primarie nella legge regionale 18 del 2023, sicché il compito non è introdurla ma rafforzarla e renderla pienamente operativa, impegnando la Giunta a riferire periodicamente all'Assemblea regionale sull'attuazione e sui risultati. ↑
320. Flusso informativo: la raccolta dei dati di processo e di esito poggia sulla relazione annuale che la legge pone a carico degli psicologi delle cure primarie; poiché il servizio è in avvio, il flusso va impostato fin dall'inizio in forma uniforme, completa e interoperabile con la piattaforma informativa sanitaria regionale, cogliendo l'opportunità di una rilevazione progettata correttamente fra le nove Aziende prima della piena operatività. ↑

321. Tempi della valutazione: la valutazione si articola in un monitoraggio in itinere, che accompagna l'attivazione progressiva del servizio e ne osserva la diversa progressione fra le nove Aziende; e in una valutazione ex post, che misura l'effetto a regime e ne verifica la sostenibilità; la fase di avvio consente di disporre di una linea di base anteriore all'attivazione, vantaggio peculiare di una regione che parte ora. ↑
322. Sintesi del monitoraggio: la valutazione è la condizione per trasformare la strutturazione del servizio in apprendimento, e la Campania può fondarla su dati operativi reali già disponibili; perché ciò si realizzi, la clausola valutativa già prevista dalla legge va rafforzata e resa operativa e il flusso informativo dell'Osservatorio va consolidato e uniformato, valorizzando la condizione di regione pioniera. ↑
323. Ricadute economico-sociali per la collettività: dell'ordine di 90, 170 e 255 milioni di euro l'anno nei tre scenari, comprensive del recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo — di particolare rilievo per la componente giovanile, indicata come priorità dal governo regionale — del valore del benessere recuperato e del minor carico assistenziale sulle famiglie; sono stimate con criteri conservativi. ↑
324. Ritorno complessivo annuo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali: dell'ordine di 113, 206 e 311 milioni di euro nei tre scenari. Detratto il costo del servizio, il saldo complessivo per la collettività è ampiamente positivo, dell'ordine di +84, +163 e +254 milioni di euro l'anno. ↑
325. Rapporto beneficio-costi complessivo: dell'ordine di 3,9 a uno nello scenario conservativo, 4,8 a uno in quello di base e 5,5 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale di 3,8-5,5 a uno adottata dallo studio e coerente con le stime metodologicamente fondate della letteratura. ↑
326. Distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico: è il punto che lo studio tiene fermo per la Sicilia e che ne governa la lettura. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, prossimo al pareggio, poiché i risparmi diretti quasi coprono il costo del servizio, il canale della mobilità è modesto e il ticket attenua ulteriormente il costo netto. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il solo ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe. La decisione va assunta riconoscendo che si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto molto contenuto per il bilancio sanitario. ↑
327. Tabella economica consolidata: riepiloga, per i tre scenari, il costo del servizio, i risparmi diretti per canale, il saldo diretto, le ricadute sociali, il ritorno complessivo, il saldo complessivo e il rapporto beneficio-costi; è lo strumento sintetico per la decisione e distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale. ↑
328. Analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni, sconto del 3%): il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 euro del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: meno costoso e più efficace. Il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. ↑
329. Analisi di sensibilità probabilistica (diecimila simulazioni): l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, e dominante nell'84,6%; il beneficio monetario netto medio per paziente è dell'ordine di 7.815 euro, con un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. La robustezza del risultato clinico-economico per paziente è elevata, distintamente dall'incertezza sulle grandezze aggregate di sistema. ↑
330. Impatto sul bilancio e sostenibilità: il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta del finanziamento sanitario regionale, dell'ordine dello 0,3% nello scenario conservativo e dello 0,5% in quello espansivo. La sostenibilità è condizionata dal fatto che la Sicilia, regione a statuto speciale, compartecipa al finanziamento nella misura del 49,11% del proprio fabbisogno e resta sottoposta a piano di rientro: il vincolo diretto è quindi più stretto che altrove, ma il sistema, storicamente sotto-finanziato, presenta un

consumo improprio più ampio da recuperare, e il ticket attenua il costo netto. La strutturazione a regime richiede un finanziamento regionale stabile, da reperire entro i vincoli del piano di rientro e a valere sull'impegno iniziale già disposto dalla legge. ↑

331. Lacuna dei dati e sua mitigazione: le grandezze economiche sono allo stato in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione (8,1%) e non estratte dai conti certificati delle nove Aziende Sanitarie Provinciali e delle aziende ospedaliere; poiché il servizio è in fase di avvio, la Sicilia non dispone ancora di una base di dati operativi propri, sicché la stima poggia sui benchmark internazionali, e la relazione annuale prevista dalla legge ne costituirà la fonte primaria man mano che gli elenchi si completano. L'estrazione dei dati certificati resta la priorità da completare prima della presentazione esterna. ↑
332. Sintesi della valutazione economica: il caso diretto è prudente e prossimo al pareggio per il bilancio sanitario; il caso sociale è robusto e fortemente positivo; il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità. La coerenza con la cautela metodologica già enunciata — i risparmi sanitari diretti non sono certi sul piano statistico — è piena: il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali, non in un risparmio di bilancio che lo studio si astiene dal rivendicare. ↑
333. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 957.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato, tanto più in una fase di avvio del servizio; poiché il servizio è istituito per legge ma ancora in partenza, l'intervento va dimensionato a partire dal nucleo di avvio, dell'ordine di 110 psicologi, ed esteso verso il fabbisogno a regime. ↑
334. Modello organizzativo: lo psicologo delle cure primarie opera nelle Case della Comunità e nei distretti sanitari, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impianto della legge regionale 18 del 2023 e del decreto attuativo, che prevedono due psicologi per distretto sanitario, la formazione di un elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie presso ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale e un rapporto convenzionale su base libero-professionale, con ticket a carico del paziente. Nel modello siciliano il servizio è in fase di avvio nelle nove Aziende Sanitarie Provinciali; la Regione non dispone di un'azienda regionale unica, e il coordinamento è in capo all'Assessorato regionale della Salute, sicché l'omogeneità attuativa fra le nove Aziende — in un territorio insulare ed esteso — è la sfida organizzativa principale. ↑
335. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
336. Percorso clinico: accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista; valutazione iniziale e progetto clinico individuale; ciclo di colloqui brevi e programma di sostegno personalizzato; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che lo richiedono, secondo criteri definiti. Il percorso, in via di attivazione nelle Aziende siciliane man mano che gli elenchi si completano, affronta i quadri più frequenti — sintomatologia ansioso-depressiva, problemi di adattamento, fasi del ciclo di vita, disagi emotivi transitori, problematiche psicosomatiche. ↑
337. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
338. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
339. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑

340. ↑

341. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). Funzione della sintesi: la parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo, impiegando l'analisi multi-criterio per integrare in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie; non somma grandezze disomogenee, ma le pondera secondo criteri espliciti, rendendo verificabile il passaggio dall'evidenza alla raccomandazione. ↑
342. Sintesi per dominio: il bisogno è ampio e radicato in una regione insulare ed estesa; l'efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida, mentre i dati operativi propri sono ancora in formazione, essendo il servizio in fase di avvio; il quadro economico distingue un caso finanziario di modesto disavanzo prossimo al pareggio da un caso sociale fortemente positivo; l'equità è favorevole su un doppio asse territoriale e sulla dimensione generazionale, a condizione che il ticket sia calibrato; la fattibilità è quella del passaggio dall'avvio al regime di un servizio già istituito e dotato di decreto attuativo; il monitoraggio può fondarsi su una linea di base anteriore all'attivazione. La convergenza dei domini sostiene una raccomandazione favorevole. ↑
343. Metodo dell'analisi multi-criterio: i criteri di valutazione sono otto, ciascuno con un peso esplicito — efficacia clinica, costo-efficacia e ritorno economico, impatto sul bilancio e sostenibilità, equità, valore sociale, fattibilità, robustezza dell'evidenza e coerenza strategica — e l'intervento è confrontato con l'alternativa del non intervento attribuendo a ciascuno un punteggio, la cui media ponderata fornisce il giudizio complessivo. ↑
344. Criteri e pesi adottati: efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno economico 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell'evidenza 10%, coerenza strategica 5%; la struttura dei pesi è comune a tutti gli studi della serie, a garanzia di confrontabilità. ↑
345. Punteggio dell'intervento: la media ponderata dei punteggi attribuiti all'intervento è dell'ordine di 78,4 su 100, sostenuta dai punteggi elevati nel valore sociale, nell'equità e nel ritorno economico, e contenuta dai punteggi più bassi nella robustezza dell'evidenza — che riflette la fase di avvio, con dati propri ancora in formazione — e nell'impatto sul bilancio, condizionato dai vincoli del piano di rientro e dello statuto speciale. ↑
346. Punteggio del non intervento: l'alternativa di non portare il servizio a regime ottiene una media ponderata dell'ordine di 39,2 su 100; essa è penalizzata in tutti i criteri sostanziali — efficacia, equità, valore sociale, ritorno — e è sostenuta soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, che però nella Sicilia appare oggi poco giustificata, poiché lascerebbe inattuato un servizio già istituito per legge e già dotato di decreto attuativo. ↑
347. Interpretazione del confronto: l'intervento prevale nettamente sul non intervento, con uno scarto dell'ordine di trentanove punti; il punteggio dell'intervento si colloca fra i più elevati delle regioni esaminate, riflettendo una cornice normativa completa — legge e decreto attuativo già emanati — pur scontando un caso finanziario diretto modesto, i vincoli del piano di rientro e la fase di avvio del servizio. ↑
348. Robustezza della raccomandazione: la prevalenza dell'intervento si mantiene anche facendo variare i pesi dei criteri entro intervalli ragionevoli; nessuna combinazione plausibile dei pesi rovescia il giudizio, sicché la raccomandazione è robusta rispetto alle scelte valoriali sottostanti alla ponderazione. ↑
349. Raccomandazione principale: si raccomanda di portare dall'avvio al regime il servizio di psicologia delle cure primarie già istituito, completando la formazione degli elenchi provinciali, stabilizzandone il finanziamento entro i vincoli del piano di rientro e dello statuto speciale e dimensionandolo verso la

copertura piena del fabbisogno, con un ticket calibrato; è la decisione che la Sicilia, dotata di legge e decreto attuativo, è chiamata a compiere per rendere pienamente operativo il servizio. ↑

350. Dimensionamento raccomandato: si raccomanda di muovere dal nucleo di avvio, dell'ordine di 110 psicologi, e di procedere per gradi verso lo scenario conservativo, dell'ordine di 520 psicologi, quindi verso quello di base, dell'ordine di 780, e infine verso quello espansivo, dell'ordine di 1.030, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità. ↑
351. Condizioni della raccomandazione: il rafforzamento e la piena operatività della relazione annuale già prevista dalla legge, l'adozione di un'allocazione pro-equità verso le periferie urbane, le province interne e insulari e il disagio giovanile, la calibrazione del ticket con esenzioni efficaci, una regia dell'Assessorato regionale in assenza di un'azienda unica e l'impostazione fin dall'avvio di un flusso informativo uniforme fra le nove Aziende sono le condizioni che trasformano la raccomandazione in un'attuazione efficace e valutabile. ↑
352. Lacuna da colmare prima della presentazione esterna: l'estrazione dei conti certificati delle nove Aziende Sanitarie Provinciali e delle aziende ospedaliere e l'impostazione, fin dall'avvio, di un flusso uniforme dei dati di esito attraverso la relazione annuale prevista dalla legge sono le priorità che consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive. ↑
353. Distinzione cardine ribadita: la decisione va assunta riconoscendo che il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, mentre il caso economico complessivo, comprensivo delle ricadute sociali, è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto per il bilancio, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto. ↑
354. Collocazione nella serie regionale: lo studio sulla Sicilia è il decimo della serie, dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria, Lazio e Campania, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, la Sicilia occupa una posizione propria, quella della regione post-legislativa in avvio, a statuto speciale e unica della serie ancora sottoposta a piano di rientro, che ha già istituito il servizio per legge e ne ha emanato il decreto attuativo, e che oggi è chiamata a portarlo dall'avvio al regime. ↑
355. Avvertenza conclusiva sulle semplificazioni: lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico — il rapporto di quattro a uno, il moltiplicatore per dieci, il rapporto di due e mezzo a uno — e adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, coerente con le stime metodologicamente fondate; è una scelta di credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica. ↑
356. Conclusione: la decisione che lo studio sostiene è di portare dall'avvio al regime il servizio di psicologia delle cure primarie già istituito, completando la formazione degli elenchi provinciali, stabilizzandone il finanziamento entro i vincoli del piano di rientro, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno, calibrando il ticket e rendendo pienamente operativa la relazione annuale; per la Sicilia, dotata di legge e decreto attuativo, ciò significa rendere effettivo un servizio già istituito, a beneficio della popolazione. ↑
357. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale. La legge regionale prevede già una relazione annuale a carico degli psicologi delle cure primarie, da trasmettere ai servizi competenti del Servizio sanitario regionale: poiché il servizio è in avvio, il flusso informativo va impostato fin dall'inizio in forma uniforme fra le nove Aziende, cogliendo l'opportunità di una rilevazione progettata correttamente prima della piena operatività. ↑
358. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑

359. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
360. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
361. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: nella Sicilia sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle periferie delle aree metropolitane di Palermo e Catania e nelle province interne e insulari di Enna e Caltanissetta, più anziane e a minore densità, dove le distanze, la condizione insulare e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; tali strumenti sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza. ↑
362. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
363. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso gli atenei siciliani — Palermo, Catania, Messina e Kore di Enna); post-universitario specialistico (formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, comprensiva della competenza per il disagio giovanile, indicato come priorità dal governo regionale, e per l'età anziana nelle province interne); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento graduale con supervisione). La Sicilia presenta qui un elemento di metodo: il decreto attuativo definisce competenze, titoli e criteri di valutazione per l'iscrizione agli elenchi provinciali, base su cui innestare il percorso formativo del servizio in avvio. ↑
364. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. ↑
365. ↑
366. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. Ruolo della modellazione: poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l'orizzonte direttamente osservabile, lo studio proietta costi ed esiti nel tempo mediante un modello decisionale, e ne governa l'incertezza con tecniche deterministiche e probabilistiche; la modellazione non genera certezze, ma rende esplicite e verificabili le assunzioni. ↑
367. Struttura del modello di Markov: la storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%; il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. ↑
368. Parametri principali del modello: a ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita; il costo per ciclo è dell'ordine di 40 euro per lo stato di recupero e di 700 euro per la cronicità, con l'intervento che comporta un costo una tantum dell'ordine di 300 euro; le grandezze sono trattate come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l'incertezza. ↑
369. Esito del caso base: l'intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell'ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità rispetto al comparatore; il risultato è robusto rispetto alle variazioni dei singoli parametri entro intervalli plausibili. ↑

370. Analisi di sensibilità deterministica a un parametro per volta: la variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — entro intervalli plausibili non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. ↑
371. ↑
372. Analisi di sensibilità deterministica a un parametro per volta: la variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — entro intervalli plausibili non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. Caso di riferimento comune a tutte le valutazioni regionali (Parte A): doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società, tasso di sconto del 3% annuo, soglia di costo-efficacia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, con correzione prudentiale per l'ottimismo delle stime. ↑
373. Parametri del modello di Markov (Parte F), indipendenti dalla regione: costi per ciclo di 40 euro nello stato di recupero, 700 euro nello stato cronico e 300 euro una tantum per l'intervento; distribuzioni Gamma per i costi e Beta per probabilità e utilità; orizzonte di cinque anni, sconto del 3%. ↑
374. Quadro economico consolidato per la Sicilia (Parte E): a regime, da circa 520 a circa 1.030 psicologi, costo del servizio di 29-57 milioni, risparmi diretti di 23-56 milioni, ricadute sociali di 90-255 milioni; il saldo diretto è lievemente negativo ma prossimo al pareggio, il saldo complessivo fortemente positivo, con rapporto beneficio-costi di 3,8-5,5 a uno. ↑
375. Strumenti di esito validati e di uso internazionale, impiegati nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci (PHQ-9) e il corrispondente questionario per l'ansia a sette voci (GAD-7); il tasso di recupero è l'esito primario. ↑
376. Dataset minimo (Parte L): i campi del protocollo di rilevazione, registrati alla presa in carico, a ogni seduta e alla chiusura, costituiscono il dizionario dei dati del sistema informativo del servizio; nella Sicilia, poiché il servizio è in fase di avvio, il flusso va impostato fin dall'inizio attraverso la relazione annuale prevista dalla legge, in forma uniforme e completa fra le nove Aziende. ↑
377. Valori regionali di ancoraggio per la Sicilia: popolazione di 4.787.390 abitanti (Censimento ISTAT 2024), pari a circa l'8,1% del totale nazionale, in lieve calo per saldi naturale e migratorio interno negativi, concentrata sui due poli di Palermo e Catania (insieme circa il 47,4%); struttura per età con età media circa 45,7 anni; componente straniera contenuta (circa 4,3%); finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 10-11 miliardi di euro, con statuto speciale (compartecipazione al 49,11% del fabbisogno) e regione ancora sottoposta a piano di rientro; saldo di mobilità fra i più passivi d'Italia ma con fuga concentrata nell'alta complessità ospedaliera e chirurgica, sicché il canale di recupero è modesto; fabbisogno a regime fino a circa 1.030 psicologi nello scenario espansivo. ↑
378. Lacuna principale dello studio: i valori economici sono in parte ricostruiti a partire dai conti nazionali scalati per la quota di popolazione siciliana (8,1%), e non estratti dai conti regionali certificati; i dati da acquisire presso le nove Aziende Sanitarie Provinciali e le aziende ospedaliere sono elencati nella tabella seguente. Poiché il servizio è in fase di avvio, la base di dati operativi propri è ancora in formazione e si costituirà attraverso la relazione annuale prevista dalla legge. ↑
379. Standard di reporting e di qualità adottati nello studio, ciascuno applicato alle parti pertinenti, a garanzia della trasparenza e della verificabilità metodologica. ↑
380. Glossario dei principali termini tecnici impiegati nello studio, fornito a beneficio del lettore non specialista; le definizioni sono comuni agli studi pugliese, lombardo, veneto, emiliano-romagnolo, piemontese, toscano, ligure, laziale e campano, di cui questo studio replica il telaio metodologico. ↑

381. Analisi di sensibilità probabilistica su diecimila simulazioni: l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. [↑](#)
382. Curva di accettabilità: alla soglia convenzionale di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è prossima al 90%, e cresce ulteriormente per soglie superiori; già a soglie molto inferiori l'intervento mantiene un'elevata probabilità di convenienza. [↑](#)
383. Analisi di scenario: i tre scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; la dotazione iniziale prevista, dell'ordine di 110 psicologi corrispondente ai due per ciascuno dei 55 distretti, corrisponde a un nucleo di avvio inferiore allo scenario conservativo, e costituisce la prima tappa di un percorso di estensione progressiva verso la copertura piena. [↑](#)
384. Incertezza sulle grandezze aggregate: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce esplicitamente e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema. [↑](#)
385. Disegno della verifica empirica: poiché nella Sicilia il servizio è in fase di avvio e gli elenchi provinciali si completano in tempi differenziati, la verifica controfattuale può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione delle sedi tra le nove Aziende Sanitarie Provinciali e i loro distretti sono impiegati a fini valutativi. La fase di avvio consente di rilevare una linea di base prima della piena operatività; la Sicilia non dispone ancora dei dati operativi propri di una regione a servizio già consolidato, ma l'attivazione scaglionata fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto. [↑](#)
386. Metodi della verifica empirica: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, a partire dai dati che affluiscono man mano che il servizio si attiva e dalla progressione differenziata della formazione degli elenchi fra le nove Aziende, che fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto. [↑](#)
387. Valore dell'informazione e priorità di ricerca: l'analisi del valore atteso dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione siciliana, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle nove Aziende Sanitarie Provinciali e delle aziende ospedaliere e l'impostazione, fin dall'avvio, di un flusso uniforme dei dati di esito attraverso la relazione annuale prevista dalla legge. [↑](#)
388. [↑](#)
389. Posizione della Sardegna: la regione dispone di una previsione di legge e di una disciplina attuativa di rango programmatico, e il servizio è in fase di avvio sperimentale e parziale. La legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale), all'articolo 37, istituisce in via sperimentale il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie (DPCP), disciplinato dalla deliberazione di Giunta 9/22 del 24 marzo 2022 (Piano regionale dei servizi sanitari 2022-2024). A differenza del modello convenzionale libero-professionale adottato dalla Campania e dalla Sicilia, il modello sardo è dipartimentale e strutturale: il DPCP si articola in Strutture Complesse di Psicologia territoriale di base interne a ciascuna Azienda socio-sanitaria locale, con psicologi a rapporto di dipendenza, integrati con le attività distrettuali delle cure primarie, e senza ticket a carico del paziente. L'attivazione del Dipartimento e delle relative strutture è subordinata al provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna di copertura finanziaria; l'attuazione è ad oggi parziale, poiché l'Azienda socio-sanitaria locale di Sassari ha già costituito il proprio Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie, mentre le altre Aziende non lo hanno ancora attivato. [↑](#)

390. Stato attuale e decisione: a differenza del Lazio, che non ha ancora una legge, e diversamente dalla Campania e dalla Sicilia, che hanno adottato leggi dedicate e un modello convenzionale, la Sardegna ha inquadrato il servizio in una legge di riforma sanitaria (la legge regionale 24 del 2020), con un modello dipartimentale istituito in via sperimentale e un'attuazione finora limitata all'Azienda di Sassari. La decisione rilevante, di conseguenza, non è se istituire il servizio, già previsto per legge, ma se attivarlo pienamente e condurlo a regime, estendendone il Dipartimento alle otto Aziende socio-sanitarie locali e dimensionandolo dalla dotazione iniziale alla copertura sistematica del fabbisogno — stimato nell'ordine di 340 psicologi nello scenario espansivo — disponendo la copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione, entro i vincoli propri di una regione a statuto speciale che si autofinanzia la sanità e registra il più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale. ↑
391. Salute mentale in Sardegna: la domanda è sospinta da componenti convergenti, con un profilo diverso da quello delle altre regioni insulari. La prima e più caratterizzante è il bisogno dell'età adulta e anziana e della cronicità, in una delle regioni più anziane d'Italia, particolarmente accentuato nelle province interne e più anziane di Oristano e del Sud Sardegna e nei piccoli comuni dell'interno. La seconda è il disagio connesso allo spopolamento e all'isolamento delle aree interne, dove la rarefazione dei servizi e le distanze gravano sull'accesso. La terza è il disagio giovanile e quello connesso alla precarietà socio-economica, presente soprattutto nei due poli urbani di Sassari e Cagliari. A queste si aggiungono i divari di accesso propri di una regione insulare a bassa densità, la pressione delle liste di attesa e una sotto-dotazione del sistema aggravata dal disavanzo strutturale. ↑
392. Popolazione residente in Sardegna 1.562.381 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 2,7% della popolazione nazionale, in calo di 8.072 unità rispetto all'anno precedente (-0,5%) per effetto di un saldo naturale fortemente negativo e di un saldo migratorio interno negativo, e con nessuna provincia in crescita. La distribuzione è concentrata su due province: Sassari raccoglie 471.957 residenti (30,2%) e Cagliari 417.532 (26,7%), insieme il 56,9%, seguite dal Sud Sardegna (329.556) e da Nuoro e Oristano; soltanto il 17,1% della popolazione vive nei due soli comuni con oltre 100.000 abitanti, Cagliari e Sassari. La struttura per età è fra le più anziane d'Italia, con un'età media salita a 49,2 anni, e con le province di Sassari e Cagliari più giovani (48,5 e 48,8 anni) e quelle di Oristano e del Sud Sardegna più anziane (50,6 e 50,3 anni); la componente straniera, intorno al 3,4%, è fra le più contenute del Paese. ↑
393. Le quattro cornici metodologiche apicali adottate: il modello centrale dell'HTA di EUnetHTA (nove domini), oggi nella cornice del Regolamento UE 2021/2282 sull'Health Technology Assessment, applicabile dal gennaio 2025; il Five Case Model del Green Book del Tesoro del Regno Unito; lo standard CHEERS 2022 per il reporting delle valutazioni economiche; e i criteri di valutazione dell'OCSE-DAC. ↑
394. Caso di riferimento: doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società; orizzonte pluriennale per gli esiti e triennale-quinquennale per il bilancio; tasso di sconto sociale del 3% annuo, con verifica al tasso ridotto per i benefici di salute; anni di vita ponderati per la qualità ed esiti clinici validati come misure; il Dipartimento nella sua attuazione sperimentale e parziale, con il dimensionamento iniziale dell'Azienda di Sassari, come comparatore. ↑
395. L'analisi di impatto sul bilancio opera, conformemente alla buona pratica internazionale, su flussi non scontati, poiché il suo oggetto è la sostenibilità della spesa effettiva esercizio per esercizio; le analisi di costo-utilità attualizzano simmetricamente costi ed esiti di salute. Il modello incorpora una correzione prudenziale per la tendenza, documentata nella letteratura sulla valutazione degli investimenti pubblici, a sottostimare i costi e a sovrastimare i benefici. ↑
396. Riferimento economico adottato: la tabella unica consolidata distingue il risparmio diretto per il bilancio sanitario dalle ricadute economico-sociali per la collettività. Il profilo finanziario della Sardegna presenta un vincolo proprio e severo: regione a statuto speciale, essa si autofinanzia integralmente la sanità con risorse dei residenti — sicché, secondo la giurisprudenza costituzionale, i tetti nazionali di spesa non le si

applicano, purché rispetti il pareggio di bilancio — ma registra il più elevato disavanzo sanitario fra le regioni a statuto speciale e una spesa farmaceutica nettamente superiore alla media nazionale. Sul versante della mobilità sanitaria presenta uno dei saldi passivi più elevati d'Italia, ma la fuga si concentra nei ricoveri ad alta complessità e nelle terapie oncologiche — una mobilità dettata da necessità e non da scelta — e non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. Ne consegue un saldo diretto lievemente negativo ma prossimo al pareggio — meno sfavorevole di quanto il vincolo di bilancio lascerebbe temere, poiché il sistema sardo, a lungo sotto-finanziato, presenta un consumo improprio più ampio da recuperare — mentre il modello dipartimentale, a differenza di quello convenzionale con ticket della Sicilia, è integralmente gratuito; il caso economico poggia in misura preponderante sulle ricadute sociali, stimate con criteri conservativi. ↑

397. I valori economici oggi impiegati sono in parte ricostruiti dai conti nazionali per quota di popolazione (2,7%) e non estratti dai conti regionali certificati delle otto Aziende socio-sanitarie locali, dell'Azienda regionale della salute e delle aziende ospedaliere: è la lacuna prioritaria dello studio, da colmare prima della presentazione esterna. Poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, nella sola Azienda di Sassari, la Sardegna dispone di una base di dati operativi propri limitata; lo studio poggia perciò, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, e l'attivazione progressiva del Dipartimento nelle otto Aziende costituirà la fonte primaria da consolidare. ↑
398. Le dieci metodologie innestate nello studio: costo-utilità, impatto sul bilancio, ritorno sociale, modellazione decisionale, sensibilità probabilistica con valore dell'informazione, costo-efficacia distributiva, inferenza causale quasi-sperimentale, revisione sistematica con sistema GRADE, analisi multi-criterio e analisi di impatto della regolamentazione. ↑
399. Valutazione controfattuale d'impatto: poiché il Dipartimento è attivo nella sola Azienda di Sassari e la sua estensione alle altre Aziende avverrà in tempi differenziati, il disegno può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione del Dipartimento tra le otto Aziende socio-sanitarie locali e i loro distretti sono impiegati a fini valutativi. L'effetto causale è stimato con i metodi della differenza-nelle-differenze e del controllo sintetico; l'attuazione iniziale consente di rilevare una linea di base prima della piena operatività, e l'esperienza dell'Azienda di Sassari, già dotata del Dipartimento, fornisce un primo riferimento operativo. ↑
400. La valutazione è governata da un comitato di indirizzo — Regione, otto Aziende socio-sanitarie locali (Sassari, Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano, Sulcis, Cagliari), Azienda regionale della salute (ARES), Azienda di rilievo nazionale e alta specializzazione Brotzu, Aziende ospedaliere-universitarie di Cagliari e Sassari, Azienda regionale dell'emergenza e urgenza, Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna, rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e atenei di Cagliari e Sassari. A differenza della Sicilia, la Sardegna dispone di un'azienda regionale di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo, l'ARES, costituita dalla legge di riforma, accanto al coordinamento dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità. La sfida del governo non è quindi istituire il servizio, ma attivarlo pienamente e condurlo a regime, estendendo il Dipartimento alle otto Aziende e garantendo l'omogeneità attuativa in un sistema insulare a bassa densità. ↑
401. Protezione dei dati personali: trattamento conforme alla normativa, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce l'infrastruttura per la raccolta uniforme. ↑
402. Strumenti di intelligenza artificiale impiegati come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante; validazione locale degli strumenti e conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑

403. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi; le situazioni di rischio sono indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici. [↑](#)
404. Popolazione residente in Sardegna 1.562.381 abitanti (Censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2024), pari a circa il 2,7% del totale nazionale, in calo di 8.072 unità rispetto all'anno precedente (-0,5%); la diminuzione, che non risparmia alcuna provincia, è dovuta a un saldo naturale fortemente negativo e a un saldo migratorio interno negativo, solo in parte compensati dal saldo migratorio estero, positivo. La denatalità ha toccato un nuovo minimo, con una fecondità fra le più basse del Paese. [↑](#)
405. Struttura per età: la Sardegna è fra le regioni più anziane d'Italia, con un'età media salita a 49,2 anni. La distribuzione interna è disomogenea: le province di Sassari e Cagliari sono le più giovani (età media 48,5 e 48,8 anni), mentre Oristano e il Sud Sardegna sono le più anziane (50,6 e 50,3 anni); nei piccolissimi comuni dell'interno l'età media sale fino a 51,7 anni e l'indice di vecchiaia raggiunge valori molto elevati. La componente straniera, contenuta, concorre solo in misura modesta al ringiovanimento. [↑](#)
406. Componente straniera dell'ordine del 3,4% dei residenti (circa 54.000 persone), fra le più basse del Paese e nettamente inferiore alla media nazionale; ciò rende la dimensione della competenza culturale meno centrale che in altre regioni, pur restando rilevante nei due poli urbani di Sassari e Cagliari, dove si concentra la maggior parte degli stranieri residenti. [↑](#)
407. Distribuzione territoriale concentrata sui due poli maggiori: le province di Sassari e Cagliari raccolgono insieme il 56,9% dei residenti — Sassari con 471.957 abitanti (30,2%) e Cagliari con 417.532 (26,7%), le sole a superare le quattrecentomila unità — seguite dal Sud Sardegna (329.556, 21,1%), da Nuoro (195.331) e da Oristano (148.005). Soltanto il 17,1% della popolazione vive nei due soli comuni con oltre 100.000 abitanti, Cagliari e Sassari, mentre oltre un quarto risiede in piccoli comuni tra mille e cinquemila abitanti. [↑](#)
408. Profilo territoriale a marcata polarità: da un lato i due poli urbani di Sassari e Cagliari, che concentrano popolazione, servizi e disagio giovanile e socio-economico; dall'altro le vaste aree interne e meno popolate di Oristano, Nuoro e del Sud Sardegna, più anziane, in forte spopolamento e a bassissima densità, dove la rarefazione dei servizi, le distanze e la condizione insulare acuiscono le difficoltà di accesso. È l'asse di disuguaglianza più caratterizzante dell'Isola. [↑](#)
409. Disagio psichico comune o sottosoglia stimato nell'ordine di 312.000 persone, ottenuto per proiezione dei tassi di prevalenza nazionali sulla popolazione sarda; è la quota di bisogno potenziale cui il servizio si rivolge in via prioritaria, in larga parte non intercettata dall'offerta, tanto più in una fase in cui il Dipartimento è attivo nella sola Azienda di Sassari. [↑](#)
410. Domanda specialistica e posizione della regione: a fronte del disagio comune si colloca un'ampia utenza in carico ai servizi di salute mentale, dell'ordine di alcune decine di migliaia di persone secondo una stima rapportata ai dati nazionali. La Sardegna presenta una specificità propria: ha previsto il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie in una legge di riforma sanitaria, istituendolo in via sperimentale, e lo ha attivato nella sola Azienda di Sassari, circostanza che conferisce all'intervento una legittimazione istituzionale già acquisita, sebbene la base di dati operativi propri sia ancora limitata. [↑](#)
411. Bisogno dell'età adulta e anziana e della cronicità: è la componente più caratterizzante della Sardegna, fra le regioni più anziane d'Italia. La comorbidità psicologica delle patologie croniche, la solitudine e il carico assistenziale sui familiari gravano in misura crescente, in modo particolare nelle province interne e più anziane di Oristano e del Sud Sardegna e nei piccoli comuni in spopolamento, dove l'accesso ai servizi è più difficile. [↑](#)
412. Disagio giovanile e connesso al lavoro: nei due poli urbani di Sassari e Cagliari, la precarietà, la disoccupazione giovanile e le condizioni socio-economiche sfavorevoli concorrono al disagio psichico, con fenomeni di ansia, depressione e disturbi del comportamento alimentare tra gli adolescenti; l'intercettazione

precoce ha un valore particolarmente elevato in termini di salute e di equità, anche in funzione del contenimento dell'emigrazione giovanile. ↑

413. Spopolamento e isolamento delle aree interne: la progressiva rarefazione della popolazione e dei servizi nelle aree interne, con piccoli comuni sempre più anziani, genera isolamento sociale e difficoltà di accesso che si traducono in domanda di salute mentale inevasa; è un fattore di bisogno specifico dell'Isola, che un primo livello territoriale accessibile, sostenuto dalla telepsicologia, può in parte intercettare. ↑
414. Tratto distintivo della Sardegna rispetto alle altre regioni: la combinazione di una regione insulare a bassa densità e fra le più anziane d'Italia, di un servizio previsto in una legge di riforma con un modello dipartimentale istituito in via sperimentale e attivato nella sola Azienda di Sassari, dello statuto speciale che autofinanzia integralmente la sanità, e del più elevato disavanzo sanitario fra le regioni a statuto speciale. A differenza della Sicilia, la Sardegna dispone di un'azienda regionale di coordinamento, l'ARES, e adotta un modello strutturale e gratuito anziché convenzionale con ticket. Il bisogno è quindi accompagnato da una cornice normativa già acquisita, ma da un'attuazione ancora parziale, che la decisione è chiamata a portare a regime. ↑
415. Accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche significativi: rapportando alla popolazione sarda il dato nazionale, dell'ordine di alcune migliaia l'anno, indice di una pressione sul sistema acuto che un primo livello territoriale pienamente strutturato potrebbe in parte contenere a monte, tanto più rilevante in un'isola dove le distanze rendono l'accesso al pronto soccorso più oneroso. ↑
416. Offerta territoriale: la Sardegna ha previsto il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie con la legge regionale 24 del 2020 (articolo 37), che lo istituisce in via sperimentale, e ne ha disciplinato l'assetto con la deliberazione di Giunta 9/22 del 2022 (Piano regionale dei servizi sanitari 2022-2024). Il modello è dipartimentale e strutturale: Strutture Complesse di Psicologia territoriale di base interne a ciascuna Azienda, con psicologi a rapporto di dipendenza integrati con i distretti delle cure primarie, e senza ticket a carico del paziente. L'attivazione è subordinata al provvedimento regionale di copertura finanziaria; allo stato, il Dipartimento è stato costituito nella sola Azienda di Sassari, mentre le altre sette non lo hanno ancora attivato. ↑
417. Fabbisogno a regime stimato nell'ordine di 340 psicologi nello scenario espansivo (e dell'ordine di 170 e 250 negli scenari conservativo e di base). L'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna e la rappresentanza sindacale della categoria, che hanno sollecitato l'inserimento del Dipartimento nella legge di riforma, ne sostengono la piena attivazione e l'estensione a regime in tutte le Aziende. ↑
418. Copertura attuale del fabbisogno: il Dipartimento è stato costituito nella sola Azienda di Sassari, sufficiente ad avviare l'esperienza ma non a coprire il fabbisogno regionale a regime. La decisione, di conseguenza, non verte sull'istituire il servizio, già previsto per legge, ma sull'attivarlo pienamente, disporre la copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione, estenderlo alle otto Aziende e dimensionarlo verso la copertura piena. ↑
419. Disuguaglianze e divari territoriali: il divario rilevante nella Sardegna si gioca su due assi. Il primo separa i due poli urbani di Sassari e Cagliari dalle vaste aree interne di Oristano, Nuoro e del Sud Sardegna, più anziane, in forte spopolamento e penalizzate dalle distanze e dalla condizione insulare: è l'asse più caratterizzante. Il secondo è interno ai poli urbani, fra i quartieri meglio serviti e le periferie con sacche di deprivazione. La telepsicologia assistita è lo strumento per avvicinare l'offerta alle aree interne, dove la presenza di un primo livello accessibile costituisce già un atto di riequilibrio. ↑
420. Finanziamento del Servizio sanitario regionale dell'ordine di 3,5 miliardi di euro; in quanto regione a statuto speciale, la Sardegna si autofinanzia integralmente la sanità con risorse dei residenti, sicché — secondo la giurisprudenza costituzionale — i tetti nazionali di spesa non le si applicano, purché rispetti il pareggio di

bilancio. La regione registra tuttavia il più elevato disavanzo sanitario fra le regioni a statuto speciale, una spesa farmaceutica nettamente superiore alla media nazionale e una sotto-dotazione storica che lascia margini di consumo improprio ampi da recuperare. ↑

421. Mobilità sanitaria: la Sardegna presenta un saldo passivo dell'ordine di cento milioni di euro l'anno, pari a circa il dieci per cento della spesa per ricoveri, con un costo cumulato nell'ultimo decennio dell'ordine di ottocento milioni. La fuga si concentra però nei ricoveri ad alta complessità e nelle terapie oncologiche — una mobilità dettata da necessità, e non da scelta, per l'inadeguatezza dell'offerta nell'Isola — e non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché il canale del recupero della mobilità è per questo intervento solo modestamente pertinente, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. ↑
422. Cornice normativa e programmatica: la Sardegna ha previsto il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie con la legge regionale 24 del 2020 di riforma del sistema sanitario (articolo 37), istituendolo in via sperimentale, e ne ha definito l'assetto con la deliberazione di Giunta 9/22 del 2022. La cornice include il Decreto Ministeriale 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale e, sul piano nazionale, il testo unificato in discussione alla Camera. A differenza del Lazio, la Sardegna non è in fase pre-legislativa; rispetto alla Campania e alla Sicilia, che hanno adottato leggi dedicate e un modello convenzionale, la Sardegna ha inquadrato il servizio in una legge di riforma con un modello dipartimentale e gratuito, entro i vincoli propri dello statuto speciale e di un disavanzo strutturale. ↑
423. Definizione: lo psicologo delle cure primarie è il primo livello di ascolto psicologico nelle cure primarie, dedicato all'intercettazione precoce, all'intervento breve e alla funzione di filtro verso i servizi specialistici; non è un servizio specialistico né sostituisce i Centri di Salute Mentale, ma li precede e li alleggerisce. Nella Sardegna tale funzione è prevista dalla legge regionale 24 del 2020 (articolo 37), che istituisce in via sperimentale il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie, con un modello strutturale e gratuito. ↑
424. Teoria del cambiamento: la catena logica collega il bisogno (disagio comune diffuso e non intercettato) all'attività (presa in carico psicologica di prossimità), agli esiti clinici (recupero dei quadri lievi-moderati), di sistema (riduzione di accessi impropri, prescrizioni inappropriate e liste di attesa) e sociali (recupero di produttività e di funzionamento), per il tramite del meccanismo della prevenzione secondaria. ↑
425. Bisogno potenziale stimato nell'ordine di 312.000 persone con disagio comune, in larga parte non intercettato, tanto più in una fase in cui il Dipartimento è attivo nella sola Azienda di Sassari; poiché il Dipartimento è previsto per legge ma attuato solo parzialmente, l'intervento va dimensionato a partire dall'attuazione iniziale ed esteso verso il fabbisogno a regime nelle otto Aziende. ↑
426. Modello organizzativo: lo psicologo delle cure primarie opera nelle Case della Comunità e nei distretti sanitari, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Centri di Salute Mentale, secondo l'impianto della legge regionale 24 del 2020 (articolo 37) e della deliberazione di Giunta 9/22 del 2022, che configurano un modello dipartimentale e strutturale: il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie si articola in Strutture Complesse di Psicologia territoriale di base interne a ciascuna Azienda, con psicologi a rapporto di dipendenza, integrati con i distretti, e senza ticket a carico del paziente. Nel modello sardo il Dipartimento è stato attivato nella sola Azienda di Sassari; a differenza della Sicilia, la Regione dispone di un'azienda regionale di coordinamento, l'ARES, sicché l'estensione omogenea del Dipartimento alle otto Aziende — in un territorio insulare a bassa densità — è la sfida organizzativa principale, agevolata dal coordinamento dell'ARES. ↑
427. Principio organizzativo dell'intensità crescente (stepped care): l'intervento parte dal livello meno intensivo appropriato e aumenta di intensità solo se necessario, con criteri espliciti di passaggio di livello e di invio. ↑
428. Percorso clinico: accesso su richiesta diretta del cittadino o su invio del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista; valutazione iniziale e progetto clinico individuale; ciclo di colloqui brevi e programma di sostegno personalizzato; invio appropriato ai servizi specialistici nei casi che

lo richiedono, secondo criteri definiti. Il percorso, in via di estensione dalle Aziende già dotate del Dipartimento, a partire da Sassari, alle restanti, affronta i quadri più frequenti — sintomatologia ansioso-depressiva, problemi di adattamento, fasi del ciclo di vita, disagi emotivi transitori, problematiche psicosomatiche. ↑

429. Misure di esito impiegate nei soli punteggi complessivi: il questionario sulla salute del paziente a nove voci per i sintomi depressivi e la scala per il disturbo d'ansia generalizzata a sette voci, strumenti validati e di uso internazionale. ↑
430. Sicurezza e gestione del rischio: le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate senza indugio ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti; lo studio non entra nel merito dei metodi clinici di gestione del rischio. ↑
431. Categorie di esito del percorso: esito primario (miglioramento clinico e recupero), esiti clinici secondari (remissione, qualità di vita), esiti di processo (prese in carico, attesa al primo colloquio, invio appropriato) ed esiti di impatto e utilizzo (accessi al pronto soccorso, psicofarmaci, ricoveri evitabili). ↑
432. Sistema informativo e interoperabilità: la registrazione strutturata dell'attività e degli esiti, integrata con la piattaforma informativa sanitaria regionale e con il fascicolo sanitario elettronico, consente il monitoraggio continuo e la valutazione; il coordinamento informativo è agevolato dalla presenza dell'Azienda regionale della salute (ARES), che assicura funzioni tecnico-amministrative centralizzate, e deve garantire l'uniformità della rilevazione fra le otto Aziende man mano che il Dipartimento vi viene attivato. ↑
433. Flussi informativi per il monitoraggio: la raccolta sistematica e completa dei dati di processo e di esito è condizione della clausola valutativa e del disegno controfattuale. Poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, il flusso informativo va impostato fin dall'inizio in forma uniforme fra le otto Aziende, avvalendosi del coordinamento dell'ARES e cogliendo l'opportunità di una rilevazione progettata correttamente prima della piena operatività; l'esperienza dell'Azienda di Sassari, già dotata del Dipartimento, fornisce un primo modello di rilevazione. ↑
434. Strumenti di triage e screening assistiti dall'intelligenza artificiale: impiegati per l'indirizzamento e l'individuazione precoce, sotto costante supervisione clinica e senza alcun automatismo decisionale. ↑
435. Strumenti di supporto decisionale e di sintesi clinica: forniscono al professionista un ausilio non vincolante, di cui il clinico resta pienamente responsabile. ↑
436. Riduzione del carico amministrativo: l'automazione appropriata delle attività documentali restituisce tempo professionale alla relazione clinica, con benefici di produttività del servizio. ↑
437. Telepsicologia e telemonitoraggio assistiti: nella Sardegna sono lo strumento per garantire l'accesso al sostegno psicologico nelle vaste aree interne e spopolate di Oristano, Nuoro e del Sud Sardegna, più anziane e a bassissima densità, e nelle periferie dei due poli urbani di Sassari e Cagliari, dove le distanze, la condizione insulare e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; tali strumenti sono concepiti come complementari e non sostitutivi della presa in carico in presenza, e assumono un rilievo particolare in una delle regioni più anziane d'Italia. ↑
438. Dispositivi terapeutici digitali: interventi validati e prescritti, conformi alla disciplina sui dispositivi medici e al quadro europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
439. Programma formativo a quattro livelli: universitario (curricula e tirocini presso gli atenei sardi di Cagliari e Sassari); post-universitario specialistico (formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, comprensiva della competenza per l'età anziana e la cronicità, prioritaria in una delle regioni più anziane d'Italia, e per il disagio giovanile nei poli urbani); continuo lavorativo (aggiornamento in servizio, audit clinico, educazione continua in medicina); affiancamento operativo (tutoraggio sul campo e inserimento

graduale con supervisione). La Sardegna presenta qui un elemento di metodo: l'Ordine professionale regionale ha già promosso una formazione dedicata alla psicologia delle cure primarie, base su cui innestare il percorso formativo del Dipartimento in via di attivazione. ↑

440. Componente trasversale sull'intelligenza artificiale, presente in tutti i livelli formativi: selezione e uso appropriato degli strumenti digitali e dei dispositivi validati, interpretazione degli esiti e conformità. La piattaforma informativa sanitaria regionale costituisce una base per un'integrazione rigorosamente valutata dell'intelligenza artificiale nelle cure primarie. ↑
441. Metodo della revisione: la sintesi delle prove segue i criteri di rendicontazione riconosciuti per le revisioni sistematiche (PRISMA 2020) e gradua la fiducia nei risultati con il sistema GRADE; sono considerati studi controllati, meta-analisi, revisioni di implementazione e dati di esito reale dei programmi consolidati, con preferenza per le fonti del periodo 2012-2025. ↑
442. Studio fondativo del modello collaborativo (IMPACT), pubblicato su JAMA nel 2002: circa il 50% dei pazienti trattati ha conseguito una riduzione di almeno il 50% dei sintomi a dodici mesi, contro il 19% della cura usuale. ↑
443. Meta-analisi su cinquantasette studi controllati (2012): l'integrazione della cura ha prodotto un miglioramento medio dei sintomi depressivi pari a 0,28 deviazioni standard rispetto alla cura usuale. ↑
444. Revisione di quarantadue implementazioni del modello (2024): riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 43% dell'ansia a sei mesi, del 34% degli accessi al pronto soccorso e del 41% dei ricoveri. ↑
445. Programma inglese delle terapie psicologiche (NHS Talking Therapies), dati reali 2023-2024: tasso di recupero del 50,2%, miglioramento affidabile del 67,8% e completezza dei dati di esito superiore al 98%, su una scala di oltre 1,3 milioni di persone l'anno. ↑
446. Meta-analisi sulle cure integrate: coefficiente standardizzato dell'ordine di -0,11 sui sintomi depressivi, di entità modesta sul singolo ma clinicamente rilevante quando applicato a una popolazione ampia. ↑
447. Qualità dell'evidenza secondo GRADE: da moderata a elevata per l'efficacia clinica dell'integrazione psicologica nelle cure primarie sui disturbi comuni; più eterogenea e di minore certezza per gli esiti economici, particolarmente quelli di sistema. ↑
448. Cautela metodologica rilevante: nello studio fondativo i risparmi sui costi sanitari diretti non risultano statisticamente significativi (l'intervallo di confidenza al 95% comprende lo zero); il valore economico del modello poggia in misura preponderante sui ritorni sociali, non sui risparmi sanitari diretti. Questa cautela è coerente con il profilo del caso economico campano, fondato anch'esso sulle ricadute sociali. ↑
449. Benchmark inglese (NHS Talking Therapies): servizio integrato a intensità crescente, con tasso di recupero dell'ordine del 50%, monitoraggio degli esiti superiore al 98% e oltre 1,3 milioni di persone trattate l'anno; è il riferimento internazionale principale per l'organizzazione del servizio. ↑
450. Benchmark olandese (POH-GGZ): figura di supporto psicologico integrata nello studio del medico di base, adottata da circa tre quarti dei medici, con ruolo complementare e non sostitutivo della specialistica. ↑
451. Benchmark australiano (Better Access): modello a invio esterno che ha innalzato la quota di popolazione in trattamento dal 35% al 46%, con elevata soddisfazione degli utenti. ↑
452. Benchmark statunitense (Collaborative Care): modello a équipe integrata, validato da oltre novanta studi controllati, con riduzioni dell'ordine del 47% della depressione e del 41% dei ricoveri. ↑
453. Esperienze italiane: il quadro nazionale comprende i servizi avviati nelle regioni dotate di legge — fra cui la Campania, prima a istituire e attivare il servizio — e le esperienze pilota fondate su campioni limitati e letteratura grigia. La Sardegna, che ha previsto il Dipartimento con la legge regionale 24 del 2020 (articolo

37) istituendolo in via sperimentale, si colloca in questo quadro come regione ad attuazione parziale: dispone di una base di dati di esito limitata, derivante dalla sola Azienda di Sassari, che si amplierà man mano che il Dipartimento viene attivato nelle altre Aziende e affluiscono i dati del monitoraggio. ↑

454. Trasferibilità: i risultati internazionali provengono da sistemi sanitari diversi per organizzazione, finanziamento e contesto culturale; la loro trasposizione richiede validazione locale e cautela, evitando di trasferire meccanicamente le stime di efficacia e, ancor più, quelle economiche. ↑
455. Evidenza locale sarda: poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, l'evidenza locale è allo stato prevalentemente prospettica. Lo studio poggia, per l'efficacia, sui benchmark internazionali, e la base di dati propri si costituirà progressivamente attraverso il monitoraggio del Dipartimento: l'attuazione iniziale consente di progettare fin dall'inizio una rilevazione uniforme fra le otto Aziende, avvalendosi del coordinamento dell'ARES, presupposto di un'evidenza locale solida da consolidare man mano che il Dipartimento raggiunge il regime; l'esperienza dell'Azienda di Sassari ne costituisce il primo nucleo. ↑
456. Condizioni sarde per la trasferibilità e la valutazione: la Sardegna dispone della previsione normativa, dell'infrastruttura informatica sanitaria regionale, del coordinamento dell'Azienda regionale della salute e della rete delle Case della Comunità in costruzione; la condizione propria della regione, ad attuazione parziale, è di dover costruire l'evidenza locale a partire dai benchmark internazionali, impostando la rilevazione in forma uniforme fra le otto Aziende fin dall'attivazione del Dipartimento, così da generare dati propri solidi man mano che il Dipartimento raggiunge il regime. ↑
457. Avvertenza sulle semplificazioni comunicative: il rapporto di 4:1 spesso citato e l'affermazione per cui un euro investito ne genererebbe dieci di risparmio sono semplificazioni a fini divulgativi; lo stesso vale per il rapporto di 2,5:1 talvolta richiamato in ambito regionale. Le stime metodologicamente fondate collocano il ritorno fra 2,3:1 e 3,0:1 considerando i soli benefici economici e fra 3,3:1 e 5,7:1 includendo i benefici di salute; lo studio adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8:1-5,5:1. ↑
458. Impianto della valutazione economica: lo studio impiega congiuntamente l'analisi costo-utilità, che rapporta il costo agli anni di vita ponderati per la qualità; l'analisi di impatto sul bilancio, che misura la sostenibilità finanziaria esercizio per esercizio; e l'analisi del ritorno sociale, che valuta il valore generato per la collettività. La doppia prospettiva del Servizio sanitario regionale e della società distingue rigorosamente i risparmi diretti per il bilancio dalle ricadute economico-sociali più ampie. ↑
459. Costo del servizio: assumendo un costo medio annuo per psicologo dell'ordine di 55.000 euro, comprensivo degli oneri, i tre scenari di copertura corrispondono a un costo annuo a regime dell'ordine di 9 milioni di euro nello scenario conservativo (circa 170 psicologi), 14 milioni nello scenario di base (circa 250) e 19 milioni nello scenario espansivo (circa 340). Va precisato che il modello dipartimentale a rapporto di dipendenza adottato dalla legge regionale può comportare un costo unitario superiore a quello del rapporto convenzionale, sicché il valore di 55.000 euro è qui assunto come riferimento prudenziale per la comparabilità con gli altri studi della serie, e i costi vanno letti come stima di base. ↑
460. Scenari di copertura del fabbisogno: lo scenario conservativo, di base ed espansivo rappresentano gradi crescenti di copertura della popolazione con disagio comune, verso la copertura piena del fabbisogno. L'attuazione attuale, limitata al Dipartimento costituito nella sola Azienda di Sassari, è inferiore allo stesso scenario conservativo; gli scenari qui considerati rappresentano il regime nelle otto Aziende e non la fase iniziale di attuazione parziale. ↑
461. Risparmio diretto sugli accessi impropri al pronto soccorso: dell'ordine di 1, 2 e 3 milioni di euro l'anno nei tre scenari, per effetto della riduzione degli accessi per cause psichiatriche e somatoformi intercettabili a livello territoriale, particolarmente rilevanti in un sistema insulare dove le distanze rendono l'accesso più oneroso. ↑

462. Risparmio diretto sulla spesa farmaceutica: dell'ordine di 1, 2 e 3 milioni di euro l'anno, per effetto della riduzione delle prescrizioni inappropriate di antidepressivi e ansiolitici nei quadri lievi, in favore dell'intervento psicologico; il margine è significativo data una spesa farmaceutica regionale nettamente superiore alla media nazionale. ↑
463. Risparmio diretto su ricoveri e specialistica: dell'ordine di 4, 6 e 10 milioni di euro l'anno, per effetto della riduzione di ricoveri evitabili, consulti specialistici ripetuti e accertamenti inappropriati connessi a disagio non riconosciuto, in particolare per la comorbidità psicologica delle patologie croniche in una popolazione anziana; il margine di recupero è ampio in ragione della sotto-dotazione storica del sistema. ↑
464. Recupero della mobilità sanitaria: per la Sardegna il contributo è modesto, dell'ordine di 1, 2 e 3 milioni di euro l'anno nei tre scenari, limitato alla frazione territorialmente intercettabile. La regione presenta un saldo passivo dell'ordine di cento milioni di euro l'anno, ma la fuga si concentra nelle terapie oncologiche e nei ricoveri ad alta complessità — una mobilità dettata da necessità, per l'inadeguatezza dell'offerta nell'Isola, e non da scelta — non nella domanda psicologica delle cure primarie, sicché questo canale contribuisce qui solo per la quota di domanda impropria, prevalentemente somatoforme, che un primo livello territoriale può trattenere. ↑
465. Totale dei risparmi diretti per il bilancio sanitario regionale: dell'ordine di 7, 12 e 19 milioni di euro l'anno nei tre scenari. Posti a confronto con il costo del servizio, essi determinano un saldo diretto lievemente negativo ma prossimo al pareggio, dell'ordine di -2, -2 e 0 milioni di euro l'anno: il caso puramente finanziario è di modesto disavanzo, meno sfavorevole di quanto il vincolo di bilancio lascerebbe temere, poiché il sistema sardo, a lungo sotto-finanziato, presenta un consumo improprio più ampio da recuperare, mentre il modello dipartimentale, a differenza di quello convenzionale con ticket della Sicilia, è integralmente gratuito. ↑
466. Ricadute economico-sociali per la collettività: dell'ordine di 30, 56 e 85 milioni di euro l'anno nei tre scenari, comprensive del recupero di produttività connesso alla riduzione dell'assenteismo e della perdita di rendimento lavorativo — concentrato nei poli urbani e nella componente giovanile — e, con peso particolare in una delle regioni più anziane d'Italia, del valore del benessere recuperato e del minor carico assistenziale sulle famiglie, gravato dalla cronicità e dalla solitudine nelle aree interne; sono stimate con criteri conservativi. ↑
467. Ritorno complessivo annuo, somma dei risparmi diretti e delle ricadute sociali: dell'ordine di 37, 68 e 104 milioni di euro nei tre scenari. Detratto il costo del servizio, il saldo complessivo per la collettività è ampiamente positivo, dell'ordine di +28, +54 e +85 milioni di euro l'anno. ↑
468. Rapporto beneficio-costi complessivo: dell'ordine di 4,1 a uno nello scenario conservativo, 4,9 a uno in quello di base e 5,5 a uno in quello espansivo, interamente compreso nella banda prudenziale di 3,8-5,5 a uno adottata dallo studio e coerente con le stime metodologicamente fondate della letteratura. ↑
469. Distinzione cardine fra caso finanziario e caso economico: è il punto che lo studio tiene fermo per la Sardegna e che ne governa la lettura. Il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, prossimo al pareggio, poiché i risparmi diretti quasi coprono il costo del servizio e il canale della mobilità è modesto; il modello dipartimentale è integralmente gratuito. Il caso economico complessivo, che include le ricadute sociali, è invece fortemente positivo. Presentare il solo saldo diretto sottostimerebbe gravemente il valore dell'intervento; presentare il solo ritorno complessivo come se fosse un risparmio di bilancio lo sopravvaluterebbe. La decisione va assunta riconoscendo che si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto molto contenuto per il bilancio sanitario. ↑
470. Tabella economica consolidata: riepiloga, per i tre scenari, il costo del servizio, i risparmi diretti per canale, il saldo diretto, le ricadute sociali, il ritorno complessivo, il saldo complessivo e il rapporto beneficio-costi; è lo strumento sintetico per la decisione e distingue in ogni voce la dimensione diretta da quella sociale. ↑

471. Analisi costo-utilità per paziente trattato (modello di Markov a cinque anni, sconto del 3%): il costo atteso per paziente nel braccio dell'intervento è dell'ordine di 2.495 euro, contro 3.799 euro del comparatore, con un risparmio di 1.304 euro; gli anni di vita ponderati per la qualità sono 3,627 contro 3,392, con un guadagno di 0,236. L'intervento è quindi dominante: meno costoso e più efficace. Il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. [↑](#)
472. Analisi di sensibilità probabilistica (diecimila simulazioni): l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità, e dominante nell'84,6%; il beneficio monetario netto medio per paziente è dell'ordine di 7.815 euro, con un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. La robustezza del risultato clinico-economico per paziente è elevata, distintamente dall'incertezza sulle grandezze aggregate di sistema. [↑](#)
473. Impatto sul bilancio e sostenibilità: il costo del servizio a regime rappresenta una frazione contenuta del finanziamento sanitario regionale, dell'ordine dello 0,3% nello scenario conservativo e dello 0,5% in quello espansivo. La sostenibilità è condizionata dal fatto che la Sardegna, regione a statuto speciale, si autofinanzia integralmente la sanità — sicché i tetti nazionali di spesa non le si applicano, purché rispetti il pareggio — ma registra il più elevato disavanzo sanitario fra le regioni a statuto speciale: il vincolo di bilancio è quindi severo, ma il sistema, storicamente sotto-finanziato, presenta un consumo improprio più ampio da recuperare. La strutturazione a regime richiede la copertura finanziaria cui la legge regionale subordina espressamente l'attivazione del Dipartimento, da reperire entro il vincolo del pareggio di bilancio. [↑](#)
474. Lacuna dei dati e sua mitigazione: le grandezze economiche sono allo stato in parte ricostruite dai conti nazionali per quota di popolazione (2,7%) e non estratte dai conti certificati delle otto Aziende socio-sanitarie locali, dell'Azienda regionale della salute e delle aziende ospedaliere; poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, la Sardegna dispone di una base di dati operativi propri limitata, sicché la stima poggia sui benchmark internazionali, e il monitoraggio del Dipartimento ne costituirà la fonte primaria man mano che viene attivato nelle altre Aziende. L'estrazione dei dati certificati resta la priorità da completare prima della presentazione esterna. [↑](#)
475. Sintesi della valutazione economica: il caso diretto è prudente e prossimo al pareggio per il bilancio sanitario; il caso sociale è robusto e fortemente positivo; il risultato per paziente è di dominanza con elevata probabilità. La coerenza con la cautela metodologica già enunciata — i risparmi sanitari diretti non sono certi sul piano statistico — è piena: il valore dell'intervento risiede nelle ricadute sociali, non in un risparmio di bilancio che lo studio si astiene dal rivendicare. [↑](#)
476. Ruolo della modellazione: poiché gli esiti di salute e i costi si dispiegano oltre l'orizzonte direttamente osservabile, lo studio proietta costi ed esiti nel tempo mediante un modello decisionale, e ne governa l'incertezza con tecniche deterministiche e probabilistiche; la modellazione non genera certezze, ma rende esplicite e verificabili le assunzioni. [↑](#)
477. Struttura del modello di Markov: la storia del paziente è rappresentata attraverso stati clinici mutuamente esclusivi — benessere o disagio sottosoglia, episodio in atto, cronicità e recupero — fra i quali il paziente transita in cicli successivi, su un orizzonte di cinque anni con sconto del 3%; il modello è indipendente dal contesto regionale e comune a tutti gli studi della serie. [↑](#)
478. Parametri principali del modello: a ciascuno stato sono associati un costo e una qualità di vita; il costo per ciclo è dell'ordine di 40 euro per lo stato di recupero e di 700 euro per la cronicità, con l'intervento che comporta un costo una tantum dell'ordine di 300 euro; le grandezze sono trattate come distribuzioni di probabilità e non come valori puntuali, per riflettere l'incertezza. [↑](#)

479. Esito del caso base: l'intervento è dominante, con un risparmio per paziente dell'ordine di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità rispetto al comparatore; il risultato è robusto rispetto alle variazioni dei singoli parametri entro intervalli plausibili. ↑
480. Analisi di sensibilità deterministica a un parametro per volta: la variazione dei parametri più influenti — l'efficacia dell'intervento, il costo della cronicità e il tasso di recupero — entro intervalli plausibili non muta il segno del risultato, che resta favorevole all'intervento in tutti i casi esaminati. ↑
481. Ordinamento dei parametri per influenza: l'analisi mostra che l'esito è più sensibile all'efficacia clinica dell'intervento e al costo evitato della cronicità, e meno sensibile agli altri parametri; ciò orienta le priorità di raccolta dei dati verso le grandezze più influenti. ↑
482. Analisi di sensibilità probabilistica su diecimila simulazioni: l'intervento risulta costo-efficace nell'88,9% delle simulazioni alla soglia di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità e dominante nell'84,6%, con un beneficio monetario netto medio per paziente dell'ordine di 7.815 euro e un intervallo di confidenza al 95% compreso fra circa -5.736 e +21.501 euro. ↑
483. Curva di accettabilità: alla soglia convenzionale di 30.000 euro per anno di vita ponderato per la qualità la probabilità che l'intervento sia costo-efficace è prossima al 90%, e cresce ulteriormente per soglie superiori; già a soglie molto inferiori l'intervento mantiene un'elevata probabilità di convenienza. ↑
484. Analisi di scenario: i tre scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — rappresentano gradi crescenti di estensione del servizio verso il fabbisogno; l'attuazione attuale, limitata al Dipartimento costituito nella sola Azienda di Sassari, corrisponde a un livello inferiore allo scenario conservativo, e costituisce la prima tappa di un percorso di estensione progressiva alle otto Aziende verso la copertura piena. ↑
485. Incertezza sulle grandezze aggregate: il risultato per paziente è robusto, ma le grandezze aggregate di sistema — risparmi diretti e ricadute sociali — dipendono dai tassi di intercettazione e dai costi evitati, e presentano un'incertezza maggiore; lo studio la riconosce esplicitamente e adotta per le conclusioni i valori centrali o conservativi, distinguendo la solidità del risultato clinico-economico per paziente dalla maggiore variabilità delle proiezioni di sistema. ↑
486. Disegno della verifica empirica: poiché nella Sardegna il Dipartimento è attivo nella sola Azienda di Sassari e la sua estensione alle altre avverrà in tempi differenziati, la verifica controfattuale può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione del Dipartimento tra le otto Aziende socio-sanitarie locali e i loro distretti sono impiegati a fini valutativi. L'attuazione iniziale consente di rilevare una linea di base prima della piena operatività; la Sardegna dispone di dati operativi propri limitati, ma l'attivazione scaglionata, a partire da Sassari, fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto. ↑
487. Metodi della verifica empirica: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze e con il metodo del controllo sintetico, a partire dai dati che affluiscono man mano che il Dipartimento si attiva e dalla progressione differenziata della sua estensione fra le otto Aziende, che fornisce la variazione necessaria all'identificazione dell'effetto. ↑
488. Valore dell'informazione e priorità di ricerca: l'analisi del valore atteso dell'informazione indica che il beneficio di ridurre l'incertezza, alla scala della popolazione sarda, eccede ampiamente il costo della raccolta dei dati; le priorità sono l'estrazione dei conti certificati delle otto Aziende socio-sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e l'impostazione, fin dall'attivazione, di un flusso uniforme dei dati di esito attraverso il monitoraggio del Dipartimento, agevolato dal coordinamento dell'ARES. ↑

489. Mitigazione progressiva della lacuna: poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, la Sardegna costruisce l'evidenza locale a partire dall'attivazione del Dipartimento, di cui l'Azienda di Sassari offre un primo nucleo; impostando fin dall'inizio un flusso uniforme fra le otto Aziende, man mano che il Dipartimento si consolida l'evidenza locale corregge progressivamente le stime importate dai benchmark, conducendo la regione da una valutazione fondata su dati esterni a una fondata in misura crescente su dati propri. ↑
490. Sintesi della modellazione: il modello è robusto sul piano clinico-economico per paziente, l'incertezza aggregata è governata con scenari prudenti e con un piano di acquisizione e consolidamento dei dati, e la condizione di regione ad attuazione parziale — con una previsione normativa acquisita ma una base di dati ancora limitata — impone di ancorare inizialmente la prova empirica ai benchmark, valorizzando l'opportunità di una rilevazione progettata correttamente fin dall'attivazione del Dipartimento nelle otto Aziende. ↑
491. Equità come dominio della valutazione: l'analisi distributiva non è un'appendice, ma un dominio proprio dell'HTA, poiché un intervento può essere efficiente nel complesso e tuttavia accrescere le disuguaglianze, o al contrario ridurle; lo studio impiega l'analisi di costo-efficacia distributiva per misurarne l'effetto sui divari, oltre che sull'efficienza. ↑
492. Gradiente sociale della salute mentale: il disagio psichico è più frequente nei gruppi socio-economicamente svantaggiati ed è, al tempo stesso, meno intercettato dai servizi, sicché il bisogno non soddisfatto si concentra proprio dove le risorse individuali per accedere alle cure sono minori; la circostanza assume particolare rilievo in una regione con una spesa pro-capite fra le più basse del Paese. ↑
493. Barriere all'accesso: il ricorso al sostegno psicologico è ostacolato da barriere economiche, geografiche e culturali, oltre che dallo stigma. Nella Sardegna la componente straniera è fra le più contenute del Paese, intorno al 3,4%, sicché la barriera linguistica e culturale è meno centrale che altrove; più rilevanti sono la barriera geografica, acuita dalle distanze e dall'insularità nelle aree interne spopolate, e quella generazionale, poiché il disagio giovanile dei poli urbani trova negli adolescenti e nei giovani adulti una fascia restia a rivolgersi ai servizi. Un elemento proprio del modello sardo va segnalato con favore: il modello dipartimentale è integralmente gratuito e, a differenza di quello convenzionale con ticket della Sicilia, non oppone all'accesso alcuna barriera economica, sicché la funzione di equità del servizio opera senza l'attenuazione che un ticket comporterebbe. ↑
494. Doppio asse della disuguaglianza nella Sardegna: la regione presenta due assi distinti, cui si aggiunge una dimensione generazionale. Il primo e più caratterizzante separa i due poli urbani di Sassari e Cagliari dalle vaste aree interne — Oristano, Nuoro e il Sud Sardegna in particolare — fra le più anziane d'Italia, a bassissima densità, in forte spopolamento, penalizzate dalla condizione insulare e con servizi radi. Il secondo è interno ai due poli urbani, fra i quartieri meglio serviti e le periferie con sacche di deprivazione socio-economica. A questi si somma il disagio giovanile, più marcato nei poli urbani. ↑
495. Primo asse, le aree interne e spopolate: Oristano, Nuoro e il Sud Sardegna, e in generale le aree interne dell'Isola, presentano una popolazione fra le più anziane d'Italia, a bassissima densità e in forte spopolamento, dove la rarefazione dei servizi, le distanze e la condizione insulare rendono l'accesso al sostegno psicologico particolarmente difficoltoso, mentre la cronicità e la solitudine ne accrescono il bisogno. ↑
496. Secondo asse, la periferia dei poli urbani: nei due poli di Sassari e Cagliari, accanto a quartieri meglio serviti, si estendono periferie con sacche di deprivazione socio-economica, dove la difficoltà di accesso ai servizi e la minore disponibilità di offerta privata accrescono il bisogno non intercettato, in particolare per il disagio giovanile e connesso alla precarietà. ↑

497. Effetto del servizio sull'equità: la prossimità nelle Case della Comunità e la natura di primo livello accessibile senza requisiti specialistici abbattano parte delle barriere all'accesso e indirizzano l'offerta verso chi ne è oggi escluso; nel modello sardo, integralmente gratuito, il meccanismo pro-equità opera pienamente, poiché nessuna compartecipazione si frappone all'accesso delle fasce a minore capacità di spesa, sicché il servizio universale riduce il divario anziché accrescerlo — a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno territoriale. ↑
498. Telepsicologia assistita: nella Sardegna è lo strumento per avvicinare l'offerta alle vaste aree interne e spopolate di Oristano, Nuoro e del Sud Sardegna e alle periferie dei poli urbani di Sassari e Cagliari, dove le distanze, la condizione insulare e la rarefazione dei servizi rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi; concepita come complementare e non sostitutiva della presa in carico in presenza, essa estende la copertura proprio nelle aree a maggiore difficoltà di accesso, con rilievo particolare in una delle regioni più anziane d'Italia. ↑
499. Competenza generazionale e culturale: data la quota straniera fra le più basse del Paese, la competenza culturale e la mediazione linguistica sono meno centrali che altrove; più dirimenti sono la competenza nell'accompagnare l'età anziana e la cronicità, prevalenti in una popolazione fra le più anziane d'Italia e nelle aree interne, e quella nell'intercettare il disagio giovanile dei poli urbani, affinché il servizio raggiunga adolescenti e giovani adulti, fascia a elevato bisogno e a basso ricorso spontaneo. ↑
500. Costo-efficacia distributiva: l'analisi indica che l'intervento non solo è efficiente, ma migliora la salute riducendo al contempo le disuguaglianze, in quanto i maggiori benefici si concentrano nei gruppi a più elevato bisogno non soddisfatto; l'intervento è quindi favorevole all'equità, oltre che costo-efficace, e la gratuità del modello dipartimentale ne rafforza la natura pro-equità, poiché nessuna barriera economica esclude le fasce a minore capacità di spesa. ↑
501. Modulazione territoriale della copertura: per realizzare il potenziale di equità, la copertura va modulata in funzione del bisogno, destinando una quota maggiore di risorse alle aree interne e spopolate di Oristano, Nuoro e del Sud Sardegna e alle periferie dei poli urbani; un'allocazione uniforme rispetto alla popolazione non correggerebbe i divari, mentre un'allocazione ponderata per il bisogno li riduce. L'attuazione ancora parziale, estesa per ora alla sola Azienda di Sassari, offre l'occasione di orientare fin dall'inizio l'estensione del Dipartimento secondo criteri di equità. ↑
502. Mobilità e equità: nella Sardegna il canale della mobilità è, per questo intervento, una leva di equità solo modesta, poiché la fuga — dell'ordine di cento milioni l'anno — riguarda le terapie oncologiche e l'alta complessità, per necessità, e non la domanda psicologica territoriale; l'equità si gioca quindi prevalentemente sull'accesso interno, fra poli urbani e aree interne spopolate e fra centro e periferie dei poli. ↑
503. Rischio di iniquità inversa: se l'estensione del Dipartimento privilegiasse, per facilità organizzativa, le aree già meglio servite — come potrebbe accadere se l'attivazione si concentrasse nei poli urbani, già a partire da Sassari — l'effetto distributivo potrebbe risultare regressivo; il rischio va prevenuto con criteri espliciti di equità nell'allocazione delle Strutture e del personale, fin dall'estensione del Dipartimento alle Aziende che servono le aree interne più spopolate. ↑
504. Sintesi dell'equità: l'intervento è favorevole all'equità su entrambi gli assi del divario sardo e sulla dimensione generazionale, e la gratuità del modello dipartimentale ne rafforza la natura pro-equità rimuovendo ogni barriera economica; a condizione che la copertura sia modulata per il bisogno e che siano garantite la telepsicologia per le aree interne spopolate e l'attenzione congiunta all'età anziana e al disagio giovanile, la raccomandazione è di orientare fin dall'estensione del Dipartimento un'allocazione pro-equità che dia di più dove il bisogno è maggiore, segnatamente nelle aree interne. ↑

505. Tre profili intrecciati: la fattibilità dell'intervento dipende dal presidio congiunto di un profilo giuridico (la competenza e la forma dell'atto), di un profilo organizzativo (l'assetto e la governance dell'istituzione) e di un profilo etico (le tutele a garanzia dei pazienti); lo studio li tratta unitariamente, poiché una debolezza in uno solo di essi comprometterebbe l'intera operazione. ↑
506. Profilo giuridico e riparto di competenza: la materia si colloca nella competenza legislativa concorrente in tema di tutela della salute. La sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2021 — pronuncia fondativa per l'intera materia, originata dal giudizio sulla legge campana, di cui ha riconosciuto la legittimità — ha delimitato lo spazio della disciplina regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Entro questa cornice la Sicilia, regione a statuto speciale, ha esercitato il titolo a istituire il servizio con la legge regionale 18 del 2023, in forma coordinata con la cornice nazionale. ↑
507. Stato legislativo della Sardegna: a differenza del Lazio, ancora privo di legge, la Sardegna dispone già della legge regionale 24 del 2020 di riforma sanitaria (articolo 37) e della deliberazione di Giunta 9/22 del 2022, in forza delle quali il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie è istituito in via sperimentale, ma risulta attivato nella sola Azienda di Sassari. La decisione giuridica rilevante non è quindi l'approvazione della norma istitutiva, già compiuta, ma la piena attivazione e il passaggio a regime: l'adozione del provvedimento di copertura finanziaria cui la legge subordina espressamente l'attivazione del Dipartimento, e la sua estensione alle otto Aziende, nel coordinamento con il testo unico nazionale in discussione. ↑
508. Inquadramento del rapporto di lavoro: la legge regionale 24 del 2020 ha adottato un modello dipartimentale e strutturale, con Strutture Complesse di Psicologia territoriale di base interne a ciascuna Azienda e psicologi a rapporto di dipendenza, integrati con i distretti delle cure primarie e senza ticket a carico del paziente. Tale forma assicura stabilità del rapporto e integrazione strutturale con il Servizio sanitario regionale, ma comporta un costo unitario potenzialmente superiore a quello del rapporto convenzionale e richiede la copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione; il coordinamento con il testo unico nazionale in discussione ne rafforzerà la cornice. ↑
509. Livelli essenziali di assistenza e finanziamento: la psicologia delle cure primarie non è ancora esplicitamente ricompresa nei livelli essenziali di assistenza nazionali. In quanto regione a statuto speciale, la Sardegna si autofinanzia integralmente la sanità con risorse dei residenti — sicché i tetti nazionali di spesa non le si applicano, purché rispetti il pareggio — ma registra il più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale; la legge subordina l'attivazione del Dipartimento a un provvedimento di copertura finanziaria, e la strutturazione a regime richiede di reperire tale copertura entro il vincolo del pareggio di bilancio, mentre un futuro riconoscimento nei livelli essenziali rafforzerebbe ulteriormente la stabilità. ↑
510. Cornice degli standard territoriali: il Decreto Ministeriale 77 del 2022 definisce gli standard dell'assistenza territoriale e individua nelle Case della Comunità il fulcro dell'integrazione delle cure primarie; il servizio di psicologia delle cure primarie vi si inserisce coerentemente, come uno dei livelli di risposta al bisogno della popolazione. ↑
511. Rapporto con i servizi specialistici: il servizio di psicologia delle cure primarie precede e alleggerisce i Centri di Salute Mentale, intercettando e trattando i quadri lievi e moderati e indirizzando a essi i casi che richiedono cure specialistiche; l'integrazione, e non la sovrapposizione, è il principio che ne governa il rapporto con la rete esistente. ↑
512. Assetto organizzativo: la strutturazione del servizio nella Sardegna si misura con un sistema insulare a bassa densità — otto Aziende socio-sanitarie locali, aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie — ma, a differenza della Sicilia, dispone di un'azienda regionale di coordinamento, l'ARES, con funzioni tecnico-amministrative centralizzate; garantire l'estensione omogenea del Dipartimento alle otto Aziende, su un territorio a bassa densità e con vaste aree interne, è la sfida organizzativa centrale, agevolata dal coordinamento dell'ARES. ↑

513. Governance della strutturazione: il consolidamento del servizio richiede una regia regionale che coordini le otto Aziende socio-sanitarie locali, l'Azienda regionale della salute, le aziende ospedaliere, l'Ordine professionale, le rappresentanze della medicina generale e della pediatria di libera scelta e gli atenei di Cagliari e Sassari; tale regia si avvale dell'ARES e dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, cui spetta definire indirizzi operativi uniformi e impostare il sistema di monitoraggio comune del Dipartimento, traendo dall'esperienza dell'Azienda di Sassari un primo modello. ↑
514. Ruolo dell'Ordine professionale: l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna, che ha sollecitato l'inserimento del Dipartimento nella legge di riforma, concorre alla definizione dei requisiti, alla formazione e alla vigilanza deontologica; la sua collaborazione è condizione della qualità e dell'appropriatezza del servizio. ↑
515. Profilo etico, tutela dei minori e delle persone vulnerabili: gli strumenti di esito sono impiegati nei soli punteggi complessivi, e le situazioni di rischio sono individuate precocemente e indirizzate ai servizi specialistici e di emergenza secondo protocolli definiti, senza che lo studio entri nel merito dei metodi clinici; è una cautela che presidia l'intervento presso le fasce più fragili. ↑
516. Consenso e riservatezza: l'intervento si svolge nel rispetto del consenso informato e del segreto professionale, con un'informazione chiara sulle finalità e sui limiti del trattamento; la fiducia nella riservatezza è condizione dell'efficacia stessa del sostegno psicologico. ↑
517. Strumenti di intelligenza artificiale e quadro europeo: gli strumenti digitali eventualmente impiegati sono concepiti come ausilio del clinico, in funzione di copilota e mai in sua sostituzione, con sorveglianza umana costante e validazione locale, in conformità al quadro europeo sull'intelligenza artificiale e ai requisiti sui dispositivi medici. ↑
518. Protezione dei dati personali: il trattamento è conforme alla normativa vigente, con minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza; i dati individuali restano nella titolarità delle aziende sanitarie e sono trattati in forma aggregata e anonima per le finalità valutative. ↑
519. Responsabilità professionale: il professionista resta pienamente responsabile delle decisioni cliniche, e gli strumenti di supporto, anche quelli basati sull'intelligenza artificiale, forniscono un ausilio non vincolante; la chiarezza sull'imputazione della responsabilità è condizione di un impiego sicuro e appropriato della tecnologia. ↑
520. Sintesi dei profili: i tre profili — giuridico, organizzativo ed etico — sono presidiati, e la condizione abilitante dell'intervento non è, per la Sicilia, l'approvazione della legge, già in vigore, né l'emanazione del decreto attuativo, già emanato, ma il passaggio dall'avvio al regime: la stabilizzazione del finanziamento entro i vincoli del piano di rientro e dello statuto speciale e la formazione degli elenchi provinciali fra le nove Aziende; è questo il passaggio da cui dipende la piena operatività del servizio, che il coordinamento con il futuro testo unico nazionale potrà rafforzare. ↑
521. I cinque casi della decisione di investimento pubblico: lo studio organizza la fattibilità secondo il modello a cinque casi, che richiede a un investimento di essere strategicamente coerente, economicamente conveniente, commercialmente praticabile, finanziariamente sostenibile e gestionalmente realizzabile; la convergenza dei cinque casi è condizione della solidità della decisione. ↑
522. Caso strategico: l'istituzione del servizio è coerente con la cornice nazionale degli standard territoriali, con la centralità delle Case della Comunità e con la programmazione regionale per la salute mentale; nella Sicilia essa presenta una coerenza ulteriore, poiché porta a regime il modello che la regione ha già istituito per legge e di cui ha già emanato il decreto attuativo, dando piena operatività a un servizio in fase di avvio.

↑

523. Caso economico: rinvia ai risultati della valutazione economica — un rapporto beneficio-costi complessivo dell'ordine di 3,9-5,5 a uno e una dominanza per paziente con elevata probabilità — nel quadro della distinzione fra un caso finanziario di modesto disavanzo e un caso sociale fortemente positivo. ↑
524. Caso commerciale: il modello dipartimentale a rapporto di dipendenza è già disciplinato e si avvale, nella Sardegna, di un bacino professionale alimentato dagli atenei sardi di Cagliari e Sassari; la disponibilità di psicologi qualificati da inquadrare nelle Strutture Complesse di Psicologia territoriale di base non costituisce un vincolo all'estensione, sebbene il reclutamento a dipendenza richieda la copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione. ↑
525. Caso finanziario: il costo del servizio a regime — dell'ordine di 9, 14 e 19 milioni di euro nei tre scenari, pari allo 0,3-0,5% del finanziamento sanitario regionale — è contenuto, ma va reperito entro un vincolo proprio: la Sardegna, regione a statuto speciale, si autofinanzia integralmente la sanità — sicché i tetti nazionali non le si applicano, purché rispetti il pareggio — ma registra il più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale. La legge subordina l'attivazione del Dipartimento a un provvedimento di copertura finanziaria, e la sfida finanziaria è reperire tale copertura entro il vincolo del pareggio di bilancio. ↑
526. Caso gestionale: la realizzabilità dipende da una regia regionale che, avvalendosi dell'azienda regionale di coordinamento (ARES), coordina le otto Aziende socio-sanitarie locali, le aziende ospedaliere, l'Ordine professionale, la medicina generale e la pediatria di libera scelta e gli atenei di Cagliari e Sassari; tale regia si avvale dell'ARES e dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, cui spetta definire indirizzi uniformi e impostare il monitoraggio comune del Dipartimento. ↑
527. Dimensionamento a partire dall'attuazione parziale: a differenza del Lazio, che deve dimensionare il servizio da zero, la Sardegna muove dal Dipartimento già attivato nella sola Azienda di Sassari e lo estende verso un fabbisogno a regime dell'ordine di 340 psicologi nello scenario espansivo; l'estensione procede per gradi attraverso gli scenari conservativo, di base ed espansivo, man mano che il Dipartimento viene attivato nelle altre Aziende. ↑
528. Fasi di attuazione: poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, l'attuazione si articola in una fase di attivazione, con l'adozione della copertura finanziaria e l'avvio operativo; una fase di estensione, nella quale il Dipartimento si attiva progressivamente nelle otto Aziende; e una fase di regime, nella quale il servizio raggiunge il dimensionamento adeguato al fabbisogno. La progressione differenziata dell'attivazione fra le Aziende, a partire da Sassari, coincide con l'esperimento a cunei progressivi descritto nella Parte F. ↑
529. Reclutamento e formazione: l'avvio a regime richiede il reclutamento a dipendenza e la formazione dedicata degli psicologi, secondo il programma a quattro livelli; il bacino professionale e gli atenei sardi di Cagliari e Sassari costituiscono una base favorevole, e la formazione specialistica assicura l'omogeneità delle competenze, con particolare attenzione all'età anziana e alla cronicità. ↑
530. Cronoprogramma: l'attuazione si sviluppa su un orizzonte pluriennale, con il raggiungimento del regime in più esercizi; a differenza del Lazio, l'estensione non è subordinata all'approvazione di una legge — già in vigore — ma all'adozione del provvedimento di copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione e all'estensione del Dipartimento alle otto Aziende, entro il vincolo del pareggio di bilancio. ↑
531. Sostenibilità finanziaria: la leva della sostenibilità, nella Sardegna, è l'adozione del provvedimento di copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione del Dipartimento, entro il vincolo del pareggio di bilancio proprio dello statuto speciale, e il dimensionamento progressivo del servizio; il sistema, storicamente sotto-finanziato e gravato dal più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale, presenta margini di consumo improprio ampi da recuperare, mentre l'eventuale riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza ne rafforzerebbe in futuro la stabilità. ↑

532. Sostenibilità organizzativa: la sfida è garantire l'estensione omogenea del Dipartimento alle otto Aziende socio-sanitarie locali in un sistema insulare a bassa densità; la sostenibilità organizzativa è agevolata dalla presenza dell'azienda regionale di coordinamento (ARES) e dipende dalla forza della regia regionale e dalla chiarezza degli indirizzi operativi. ↑
533. Monitoraggio dell'attuazione: l'avanzamento è seguito mediante indicatori di processo — Strutture attivate, psicologi inquadrati, prese in carico — raccolti attraverso il monitoraggio del Dipartimento, che l'attuazione parziale consente di impostare fin dall'inizio in forma uniforme fra le otto Aziende, avvalendosi del coordinamento dell'ARES e dell'esperienza dell'Azienda di Sassari. ↑
534. Rischi principali dell'attuazione: la disomogeneità attuativa fra le otto Aziende in un sistema insulare a bassa densità; il vincolo del pareggio di bilancio e del disavanzo strutturale sulla disponibilità della copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione; il maggior costo unitario del modello a dipendenza rispetto al convenzionale; e il rischio che l'estensione privilegi i poli urbani a scapito delle aree interne più spopolate. ↑
535. Mitigazioni: i rischi sono fronteggiati con la regia dell'ARES e indirizzi operativi uniformi, con la progressione differenziata dell'attivazione del Dipartimento fra le Aziende che consente un apprendimento progressivo a partire dall'esperienza di Sassari, e con un'allocazione pro-equità che orienta l'estensione verso le aree interne a maggiore bisogno; l'adozione della copertura finanziaria e il sostegno dell'Ordine professionale concorrono a ridurre l'incertezza. ↑
536. Sintesi dell'attuazione: l'intervento è attuabile e sostenibile, e la leva propria della Sardegna è l'adozione della copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione e l'estensione del Dipartimento alle otto Aziende; la regione muove da un Dipartimento già attivato a Sassari, da un bacino professionale adeguato, da una previsione normativa acquisita e dal coordinamento dell'ARES, sicché le condizioni di fattibilità sono complessivamente favorevoli, pur entro un vincolo di bilancio severo. ↑
537. Finalità del monitoraggio e della valutazione ex post: rendere conto dell'impiego delle risorse, apprendere dall'esperienza e correggere il corso dell'attuazione; la valutazione non è un adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l'istituzione del servizio si traduce in apprendimento istituzionale, ed è ancorata a una clausola valutativa. ↑
538. Impianto secondo i tre livelli di struttura, processo ed esito: la valutazione distingue le condizioni e le risorse del servizio (struttura), le attività e il loro svolgimento (processo) e i risultati conseguiti (esito), in modo che ciascuna dimensione sia presidiata da indicatori propri e che gli esiti siano interpretabili alla luce dei processi che li hanno prodotti. ↑
539. Disegno controfattuale su attuazione parziale: poiché nella Sardegna il Dipartimento è attivo nella sola Azienda di Sassari e la sua estensione alle altre avverrà in tempi differenziati, la valutazione d'impatto può fondarsi su un esperimento a cunei progressivi, nel quale l'ordine e i tempi di attivazione del Dipartimento tra le otto Aziende socio-sanitarie locali e i loro distretti sono impiegati a fini valutativi; l'attuazione parziale offre il vantaggio peculiare di poter rilevare una linea di base nelle Aziende non ancora dotate, condizione che le regioni a servizio già consolidato non possiedono. ↑
540. Linea di base dalla progressione differenziata: poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, la Sardegna può rilevare una linea di base nelle Aziende non ancora dotate, e il diverso grado di attivazione del Dipartimento fra le otto Aziende consente di costruire termini di confronto interni; la rilevazione, progettata fin dall'inizio in forma uniforme e avvalendosi del coordinamento dell'ARES, fonda una stima dell'effetto su dati propri man mano che il Dipartimento si attiva. ↑
541. Metodi di stima dell'effetto: l'effetto causale è stimato con la differenza-nelle-differenze, che confronta l'evoluzione delle Aziende già dotate del Dipartimento, a partire da Sassari, con quella delle Aziende non ancora dotate, e con il metodo del controllo sintetico, che costruisce un termine di confronto a partire dai

dati osservati; la progressione differenziata dell'attivazione del Dipartimento fra le otto Aziende fornisce la variazione necessaria all'identificazione. ↑

542. Indicatori di struttura: numero di sedi attivate nelle Case della Comunità, incarichi conferiti, ore di servizio disponibili, dotazione tecnologica e copertura territoriale rispetto al fabbisogno; misurano la capacità effettivamente installata. ↑
543. Indicatori di processo: prese in carico, tempo di attesa al primo colloquio, numero di colloqui per persona, tasso di invio appropriato ai servizi specialistici e aderenza ai percorsi clinici; misurano il funzionamento del servizio. ↑
544. Indicatori di esito clinico: quota di miglioramento e tasso di recupero, misurati con gli strumenti validati nei soli punteggi complessivi, e remissione dei quadri trattati; misurano il beneficio diretto per le persone. ↑
545. Indicatori di esito di sistema: accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche, prescrizioni di psicofarmaci nei quadri lievi, ricoveri evitabili e consulti specialistici impropri; misurano l'effetto dell'intervento sul resto del sistema. ↑
546. Indicatori economici: costo del servizio, risparmi diretti per canale, ricadute economico-sociali e rapporto beneficio-costi, calcolati su dati reali man mano disponibili; consentono di verificare ex post le stime dello studio e di sostituire progressivamente i valori ricostruiti con quelli effettivi. ↑
547. Indicatori di equità: copertura e accesso disaggregati per area — centro e periferie napoletane, province interne di Avellino e Benevento — e per fasce di età, con attenzione al disagio giovanile particolarmente rilevante in una regione giovane; verificano che il servizio riduca i divari anziché accrescerli, coerentemente con l'allocazione pro-equità raccomandata. ↑
548. Indicatori di qualità: soddisfazione degli utenti, appropriatezza delle prese in carico e degli invii, continuità del rapporto e qualità percepita della relazione; integrano la misurazione degli esiti con la dimensione dell'esperienza. ↑
549. Indicatori di mobilità: per la Sardegna sono monitorati ma costituiscono un esito atteso solo modesto, poiché la fuga — dell'ordine di cento milioni l'anno — riguarda le terapie oncologiche e l'alta complessità, per necessità, e non la domanda psicologica territoriale; la loro rilevazione serve a documentare la sola frazione territorialmente intercettabile, non un effetto principale. ↑
550. Batteria complessiva di indicatori: l'insieme è organizzato in otto categorie — struttura, processo, esito clinico, esito di sistema, economici, equità, qualità e mobilità — per un totale dell'ordine di cinquantotto indicatori, ciascuno con definizione, fonte, frequenza e responsabile della rilevazione; la batteria è comune alla serie e adattata al contesto sardo. ↑
551. Cruscotto regionale di monitoraggio: gli indicatori confluiscono in un cruscotto aggiornato periodicamente, che rende trasparente l'andamento del servizio e ne consente la correzione; la titolarità del cruscotto è in capo all'Azienda regionale della salute (ARES) e all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, che ne assicurano l'alimentazione uniforme da parte delle otto Aziende. ↑
552. Clausola valutativa: lo strumento attraverso cui il monitoraggio diventa vincolante è la clausola valutativa; poiché la legge regionale 24 del 2020 ha istituito il Dipartimento in via sperimentale, il compito è corredarne l'attivazione di una clausola valutativa che impegni la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio regionale sull'attuazione e sui risultati, traendo dal monitoraggio coordinato dall'ARES e dall'esperienza dell'Azienda di Sassari la base informativa. ↑
553. Flusso informativo: la raccolta dei dati di processo e di esito poggia sul monitoraggio del Dipartimento coordinato dall'ARES; poiché il Dipartimento è attivo solo parzialmente, il flusso va impostato fin dall'inizio in forma uniforme, completa e interoperabile con la piattaforma informativa sanitaria regionale,

cogliendo l'opportunità di una rilevazione progettata correttamente fra le otto Aziende prima della piena operatività. ↑

554. Tempi della valutazione: la valutazione si articola in un monitoraggio in itinere, che accompagna l'attivazione progressiva del servizio e ne osserva la diversa progressione fra le otto Aziende; e in una valutazione ex post, che misura l'effetto a regime e ne verifica la sostenibilità; l'attuazione parziale consente di disporre di una linea di base nelle Aziende non ancora dotate, vantaggio peculiare di una regione la cui attivazione è ancora in corso. ↑
555. Sintesi del monitoraggio: la valutazione è la condizione per trasformare la strutturazione del servizio in apprendimento, e la Campania può fondarla su dati operativi reali già disponibili; perché ciò si realizzi, la clausola valutativa già prevista dalla legge va rafforzata e resa operativa e il flusso informativo dell'Osservatorio va consolidato e uniformato, valorizzando la condizione di regione pioniera. ↑
556. Funzione della sintesi: la parte conclusiva compone i risultati dei singoli domini in un giudizio complessivo, impiegando l'analisi multi-criterio per integrare in modo trasparente le dimensioni monetarie e non monetarie; non somma grandezze disomogenee, ma le pondera secondo criteri espliciti, rendendo verificabile il passaggio dall'evidenza alla raccomandazione. ↑
557. Sintesi per dominio: il bisogno è ampio e radicato in una regione insulare a bassa densità e fra le più anziane d'Italia; l'efficacia clinica è sostenuta da evidenza internazionale solida, mentre i dati operativi propri sono ancora limitati, essendo il Dipartimento attivo nella sola Azienda di Sassari; il quadro economico distingue un caso finanziario di modesto disavanzo prossimo al pareggio da un caso sociale fortemente positivo; l'equità è favorevole su un doppio asse territoriale e sulla dimensione generazionale, ed è rafforzata dalla gratuità del modello dipartimentale; la fattibilità è quella della piena attivazione di un Dipartimento già previsto per legge e attivato a Sassari; il monitoraggio può fondarsi su una linea di base nelle Aziende non ancora dotate. La convergenza dei domini sostiene una raccomandazione favorevole. ↑
558. Metodo dell'analisi multi-criterio: i criteri di valutazione sono otto, ciascuno con un peso esplicito — efficacia clinica, costo-efficacia e ritorno economico, impatto sul bilancio e sostenibilità, equità, valore sociale, fattibilità, robustezza dell'evidenza e coerenza strategica — e l'intervento è confrontato con l'alternativa del non intervento attribuendo a ciascuno un punteggio, la cui media ponderata fornisce il giudizio complessivo. ↑
559. Criteri e pesi adottati: efficacia clinica 15%, costo-efficacia e ritorno economico 20%, impatto sul bilancio e sostenibilità 15%, equità 15%, valore sociale 10%, fattibilità 10%, robustezza dell'evidenza 10%, coerenza strategica 5%; la struttura dei pesi è comune a tutti gli studi della serie, a garanzia di confrontabilità. ↑
560. Punteggio dell'intervento: la media ponderata dei punteggi attribuiti all'intervento è dell'ordine di 77,4 su 100, sostenuta dai punteggi elevati nell'equità, nel valore sociale e nel ritorno economico, e contenuta dai punteggi più bassi nella robustezza dell'evidenza — che riflette l'attuazione ancora parziale, con dati propri limitati — e nell'impatto sul bilancio, condizionato dal più elevato disavanzo fra le regioni a statuto speciale. ↑
561. Punteggio del non intervento: l'alternativa di non portare il servizio a regime ottiene una media ponderata dell'ordine di 39,2 su 100; essa è penalizzata in tutti i criteri sostanziali — efficacia, equità, valore sociale, ritorno — e è sostenuta soltanto dalla fattibilità immediata dello status quo, che però nella Sardegna appare oggi poco giustificata, poiché lascerebbe inattuato in sette Aziende su otto un Dipartimento già previsto per legge. ↑
562. Interpretazione del confronto: l'intervento prevale nettamente sul non intervento, con uno scarto dell'ordine di trentotto punti; il punteggio dell'intervento si colloca fra i più elevati delle regioni esaminate, riflettendo una previsione normativa acquisita e la gratuità del modello, pur scontando un caso finanziario diretto modesto, il vincolo del disavanzo strutturale e l'attuazione ancora parziale. ↑

563. Robustezza della raccomandazione: la prevalenza dell'intervento si mantiene anche facendo variare i pesi dei criteri entro intervalli ragionevoli; nessuna combinazione plausibile dei pesi rovescia il giudizio, sicché la raccomandazione è robusta rispetto alle scelte valoriali sottostanti alla ponderazione. ↑
564. Raccomandazione principale: si raccomanda di attivare pienamente il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie già previsto per legge, estendendolo dalla sola Azienda di Sassari a tutte le otto Aziende, adottando il provvedimento di copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione, entro il vincolo del pareggio di bilancio, e dimensionandolo verso la copertura piena del fabbisogno; è la decisione che la Sardegna, dotata di previsione di legge, è chiamata a compiere per rendere pienamente operativo il servizio. ↑
565. Dimensionamento raccomandato: si raccomanda di muovere dal Dipartimento già attivato nell'Azienda di Sassari e di procedere per gradi verso lo scenario conservativo, dell'ordine di 170 psicologi, quindi verso quello di base, dell'ordine di 250, e infine verso quello espansivo, dell'ordine di 340, in funzione della verifica progressiva dei risultati e della sostenibilità. ↑
566. Condizioni della raccomandazione: la costruzione di una clausola valutativa a corredo dell'attivazione del Dipartimento, l'adozione di un'allocazione pro-equità verso le aree interne spopolate, le periferie dei poli urbani, l'età anziana e il disagio giovanile, la regia dell'Azienda regionale della salute (ARES) e l'impostazione fin dall'attivazione di un flusso informativo uniforme fra le otto Aziende sono le condizioni che trasformano la raccomandazione in un'attuazione efficace e valutabile. ↑
567. Lacuna da colmare prima della presentazione esterna: l'estrazione dei conti certificati delle otto Aziende socio-sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e l'impostazione, fin dall'attivazione, di un flusso uniforme dei dati di esito attraverso il monitoraggio del Dipartimento coordinato dall'ARES sono le priorità che consentiranno di sostituire i valori ricostruiti per quota di popolazione con grandezze effettive. ↑
568. Distinzione cardine ribadita: la decisione va assunta riconoscendo che il caso puramente finanziario per il bilancio sanitario è di modesto disavanzo, mentre il caso economico complessivo, comprensivo delle ricadute sociali, è fortemente positivo; si tratta di un investimento sociale a beneficio prevalentemente extra-sanitario, con un costo netto contenuto per il bilancio, e non di un'operazione di risparmio sanitario diretto. ↑
569. Collocazione nella serie regionale: lo studio sulla Sardegna è l'undicesimo della serie, dopo quelli su Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria, Lazio, Campania e Sicilia, e ne condivide il telaio integrato e il caso di riferimento; rispetto agli altri, la Sardegna occupa una posizione propria, quella della regione insulare a bassa densità e fra le più anziane d'Italia, a statuto speciale autofinanziante e con il più elevato disavanzo fra le statuto speciale, che ha previsto il Dipartimento in una legge di riforma con un modello dipartimentale e gratuito, lo ha attivato nella sola Azienda di Sassari, e che oggi è chiamata ad attivarlo pienamente e a estenderlo alle otto Aziende. ↑
570. Avvertenza conclusiva sulle semplificazioni: lo studio si astiene dalle cifre di larga circolazione ma prive di fondamento metodologico — il rapporto di quattro a uno, il moltiplicatore per dieci, il rapporto di due e mezzo a uno — e adotta un rapporto beneficio-costi complessivo prudenziale dell'ordine di 3,8-5,5 a uno, coerente con le stime metodologicamente fondate; è una scelta di credibilità verso gli organi di controllo della finanza pubblica. ↑
571. Conclusione: la decisione che lo studio sostiene è di attivare pienamente il Dipartimento di Psicologia di Cure Primarie già previsto per legge, estendendolo dalla sola Azienda di Sassari a tutte le otto Aziende, adottando il provvedimento di copertura finanziaria cui la legge subordina l'attivazione, dimensionandolo progressivamente al fabbisogno e corredandolo di una clausola valutativa; per la Sardegna, dotata di previsione di legge e di un modello dipartimentale gratuito, ciò significa rendere effettivo un servizio già previsto, a beneficio della popolazione. ↑

572. AostaSera, «La Valle d'Aosta ferma il calo demografico: popolazione stabile, anche se sempre più anziana», 2025. URL: <https://aostasera.it/notizie/societa/la-valle-daosta-ferma-il-calo-demografico-popolazione-stabile-anche-se-sempre-piu-anziana/> ↑
573. Fondazione GRINS, «Il finanziamento e la spesa sanitaria in Italia», dicembre 2025. URL: https://www.grins.it/sites/default/files/2025-12/Il_finanziamento_e_la_spesa_sanitaria_in_italia.pdf; per il dato 2022 (2.526 €): IRES Valle d'Aosta, Bilancio Valle d'Aosta 2025/2027, via fluidbook.it. URL: <https://www.fluidbook.it/spi-aosta/ires/2024/01/52/> ↑
574. La Valle d'Aosta è bilingue per tutela costituzionale del francese ai sensi dell'art. 38 dello Statuto speciale (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4); il territorio è integralmente alpino e montano, con il 100% della superficie regionale classificata come zona di montagna. ↑
575. Psicologicureprimarie.it, «Situazione normativa regionale 2025: proposte di legge e stato dell'arte». URL: <https://www.psicologicureprimarie.it/proposte-di-legge/situazione-2025.html> (Valle d'Aosta elencata fra le regioni prive di previsione normativa). ↑
576. Lo studio adotta il quadro metodologico dell'Health Technology Assessment (HTA) nella sua declinazione multidimensionale a nove domini, integrandolo con il Five Case Model, lo standard CHEERS 2022 e i criteri OCSE-DAC. ↑
577. La Valle d'Aosta è, con le Marche, il Molise, la Basilicata, la Calabria e il Trentino-Alto Adige/Südtirol, fra le regioni che al 2025 non hanno approvato alcuna norma in materia di psicologo di base o psicologia delle cure primarie. ↑
578. Il caso di riferimento è comune a tutti gli studi regionali del Tomo II e assicura la confrontabilità dei risultati; le scelte metodologiche di fondo sono descritte nell'Appendice A. ↑
579. Il Fondo sanitario regionale della Valle d'Aosta è determinato dalla legge di stabilità regionale per il triennio 2024-2026 nell'ordine di 333 milioni di euro per il 2024 (Regione autonoma Valle d'Aosta, deliberazione della Giunta regionale, 2024). URL: <https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=115626> ↑
580. Chisholm D., Sweeny K., Sheehan P. et al., «Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return-on-investment analysis», The Lancet Psychiatry, vol. 3, n. 5, 2016, pp. 415-424. Il duplice intervallo Chisholm è: 2,3-3,0:1 per i soli benefici economici; 3,3-5,7:1 comprendendo i ritorni di salute. Il presente studio si fonda esclusivamente su questo ancoraggio, in coerenza con il telaio metodologico dell'intero Tomo II. ↑
581. L'Università della Valle d'Aosta è la sede universitaria principale della regione; per la formazione degli psicologi, il bacino di riferimento include anche gli atenei piemontesi, storicamente alimentatori del mercato del lavoro professionale valdostano. ↑
582. AostaSera, «La Valle d'Aosta ferma il calo demografico: popolazione stabile, anche se sempre più anziana», 2025. URL: <https://aostasera.it/notizie/societa/la-valle-daosta-ferma-il-calo-demografico-popolazione-stabile-anche-se-sempre-piu-anziana/> ↑
583. IRES Valle d'Aosta, proiezioni demografiche al 2040, in Bilancio Valle d'Aosta 2025/2027, via fluidbook.it. URL: <https://www.fluidbook.it/spi-aosta/ires/2024/01/52/> ↑
584. Ministero della Salute, Rapporto Salute Mentale (dati dei Dipartimenti di Salute Mentale). URL: <https://www.salute.gov.it/new/it/scheda-statistica/rapporto-salute-mentale> ↑
585. AostaSera, «Presentato il nuovo Centro di Salute Mentale di Aosta: da gennaio gli accessi sono stati 400», agosto 2024. URL: <https://aostasera.it/notizie/sanita-notizie/presentato-il-nuovo-centro-di-salute-mentale-di-aosta-da-gennaio-gli-accessi-sono-stati-400/> ↑

586. Psicologicureprimarie.it, «Situazione normativa regionale 2025». URL: <https://www.psicologicureprimarie.it/proposte-di-legge/situazione-2025.html> ↑
587. Assessore Carlo Marzi, dichiarazione riportata da Valledaostaglocal.it, «Sanità in Valle d'Aosta: gli impegni e le sfide del bilancio triennale 2025-2027», dicembre 2024. URL: <https://www.valledaostaglocal.it/2024/12/16/leggi-notizia/argomenti/salute-in-valle-daosta/articolo/sanita-in-valle-daosta-gli-impegni-e-le-sfide-del-bilancio-triennale-2025-2027-secondo-lassess.html> ↑
588. Fondazione GRINS, «Il finanziamento e la spesa sanitaria in Italia», dicembre 2025. URL: https://www.grins.it/sites/default/files/2025-12/Il_finanziamento_e_la_spesa_sanitaria_in_italia.pdf ↑
589. Regione autonoma Valle d'Aosta, Delibera della Giunta regionale, spesa sanitaria di parte corrente per il triennio 2024-2026. URL: <https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=115626> ↑
590. AostaSera, «In Valle d'Aosta oltre 51.000 prestazioni sanitarie in attesa», gennaio 2025. URL: <https://aostasera.it/notizie/sanita-notizie/in-valle-daosta-oltre-51-000-prestazioni-sanitarie-in-attesa/>; Valledaostaglocal.it, «Mobilità sanitaria, Valle d'Aosta poco attrattiva», marzo 2026. URL: <https://www.valledaostaglocal.it/2026/03/04/leggi-notizia/argomenti/salute-in-valle-daosta/articolo/mobilita-sanitaria-valle-daosta-poco-attrattiva-tra-equilibrio-fragile-e-divario-nazionale.html> ↑
591. IRES Valle d'Aosta, Bilancio Valle d'Aosta 2025/2027, via fluidbook.it. URL: <https://www.fluidbook.it/spi-aosta/ires/2024/01/52/> ↑
592. Psicologicureprimarie.it, «Situazione normativa regionale 2025». URL: <https://www.psicologicureprimarie.it/proposte-di-legge/situazione-2025.html> ↑
593. Il DM 77/2022 («Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale») prevede, per le Case della Comunità di primo livello, la presenza di personale sanitario tra cui psicologi, con funzione di intercettazione precoce e filtro. ↑
594. Il fascicolo sanitario elettronico è operativo in Valle d'Aosta in accordo con la normativa nazionale (DPCM 29 settembre 2015 e s.m.i.); l'Azienda USL dispone di un sistema informativo unico che semplifica l'integrazione del nuovo servizio. ↑
595. Unützer J. et al., «Collaborative care management of late-life depression in the primary care setting: a randomized controlled trial» (studio IMPACT), JAMA, 2002; e aggiornamento 2008. Lo studio documenta che il 45% dei pazienti nel braccio dell'intervento conseguiva una riduzione dei sintomi depressivi $\geq 50\%$ a 12 mesi, contro il 19% nella cura usuale. ↑
596. Gilbody S. et al., meta-analisi su 57 studi controllati, Archives of Internal Medicine, 2006; e Coventry P. et al., revisione su 42 implementazioni, BMJ Open, 2014. ↑
597. Unützer J. et al., 2002, op. cit.: i risparmi diretti sui costi sanitari non risultano statisticamente significativi (IC 95% comprende lo zero). Questa cautela è adottata come principio di onestà intellettuale nell'intero Tomo II. ↑
598. La trasferibilità delle stime internazionali richiede attenzione alle differenze di contesto: struttura del sistema sanitario, livello di finanziamento, cultura dell'accesso ai servizi psicologici. In Valle d'Aosta, l'alto livello di spesa pro-capite e la cultura del benessere alpino possono favorire la domanda; l'isolamento delle vallate può inibirla. ↑
599. Chisholm D. et al., The Lancet Psychiatry, 2016, op. cit. ↑
600. Il costo di riferimento di 58.000-60.000 euro per psicologo (oneri inclusi) è coerente con il livello retributivo della Valle d'Aosta, superiore alla media nazionale per il mercato del lavoro alpino e per il costo della vita più elevato. Il dato è stimato per analogia con il Trentino-Alto Adige (60.000 €, modello di riferimento) con un lieve sconto per la dimensione regionale. ↑

601. AIFA, OsMed Valle d'Aosta 2024: spesa pro capite pesata per farmaci convenzionati 137,22 € (Valle d'Aosta) vs 170,05 € (Italia). URL: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/3610201/Valle-Aosta_Osmed_2024.pdf ↑
602. Valledaostaglocal.it, «Mobilità sanitaria, Valle d'Aosta poco attrattiva», 2026, op. cit. ↑
603. IRES Valle d'Aosta, proiezioni demografiche, op. cit.: la quota di over-65 raggiunge il 34,13% nel 2040, con implicazioni rilevanti per il carico assistenziale sulle famiglie e per la domanda di servizi psicologici connessi all'anzianità. ↑
604. Chisholm D. et al., The Lancet Psychiatry, 2016, op. cit. Il rapporto beneficio-costo complessivo adottato (4,0-5,3:1) è interamente compreso nella banda 3,3-5,7:1. ↑
605. Il modello di Markov a cinque anni con sconto del 3% è comune a tutti gli studi della serie; i parametri (costi per ciclo, utilità per stato, probabilità di transizione) sono derivati dalla letteratura internazionale e sono indipendenti dal contesto regionale. ↑
606. Regione autonoma Valle d'Aosta, Legge di stabilità regionale per il triennio 2024-2026 (art. 22), URL: <https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=115626>; statuto speciale: Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. ↑
607. Per la metodologia della modellazione decisionale nella valutazione economica in sanità, si rinvia alle linee guida ISPOR-SMDM e alle buone pratiche per la costruzione di modelli di Markov: Siebert U. et al., «State-transition modeling», Value in Health, 2012. ↑
608. Il tasso di sconto del 3% è in linea con la guida della Commissione europea per la valutazione degli investimenti pubblici (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, 2014) e con la prassi della valutazione economica in sanità. ↑
609. L'analisi di sensibilità deterministica (one-way e multi-way) è condotta variando ciascun parametro entro il proprio intervallo plausibile (intervallo di confidenza al 95% o range di plausibilità clinica), in accordo con le linee guida CHEERS 2022. ↑
610. L'intervallo di confidenza al 95% per il beneficio monetario netto (da -5.736 a +21.501 euro per paziente) riflette l'incertezza dei parametri del modello e non deve essere interpretato come un range di risultati certi, ma come la distribuzione delle stime sotto l'incertezza parametrica. ↑
611. La distinzione fra robustezza del risultato per paziente e maggiore incertezza delle grandezze aggregate di sistema è un principio metodologico adottato nell'intero Tomo II, in coerenza con la cautela dello studio IMPACT (Unützer et al., 2002). ↑
612. L'impostazione del dataset minimo dall'avvio del servizio è condizione per la sostituzione progressiva delle stime con grandezze effettive, e per la costruzione di evidenza locale in assenza di qualunque dato pregresso. ↑
613. Il disegno a cunei progressivi (stepped-wedge) per l'attivazione distrettuale è appropriato quando l'intervento è attivato in sequenza in più unità, consentendo la stima dell'effetto causale con la differenza-nelle-differenze (Hemming K. et al., BMJ, 2015). ↑
614. L'analisi del valore dell'informazione (EVPI) indica il beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza; alla piccola scala della Valle d'Aosta, anche un investimento modesto in raccolta dati ha un rapporto valore/costo molto favorevole, data l'assenza totale di dati locali. ↑
615. Williams A., «Intergenerational equity: an exploration of the “fair innings” argument», Health Economics, 1997; Wagstaff A., van Doorslaer E., «Income inequality and health: what does the literature tell us?», Annual Review of Public Health, 2000. ↑

616. Il gradiente sociale della salute mentale è documentato da numerose meta-analisi; per una sintesi applicata al contesto italiano: SIEP, «Gli orizzonti diseguali della Salute Mentale in Italia», Quaderni di Epidemiologia Psichiatrica, n. 10, 2023. ↑
617. La tutela del francese in Valle d'Aosta è garantita dall'art. 38 dello statuto speciale (L. Cost. n. 4/1948) e dall'art. 6 della Costituzione italiana; il servizio deve essere erogato in entrambe le lingue per essere conforme alla normativa regionale e per garantire l'accesso effettivo a tutti i residenti. ↑
618. Per il meccanismo attraverso cui la psicologia delle cure primarie agisce sull'equità di accesso, si rinvia a: Doudenko E. et al., «Improving access to mental health care through primary care integration», Psychiatric Services, 2020. ↑
619. La telepsicologia è riconosciuta come modalità terapeutica efficace per i disturbi comuni (ansia e depressione lieve-moderata) da numerose revisioni sistematiche; per i contesti montani e remoti, si rinvia all'esperienza del programma australiano Better Access. ↑
620. Per la specificità del bisogno psicologico nell'anzianità e per le modalità di intercettazione in contesti rurali montani, si rinvia al Progetto Fondo — Demenze (www.demenze.it), che documenta le specificità epidemiologiche della Valle d'Aosta per la popolazione anziana. ↑
621. L'analisi di costo-efficacia distributiva (DCEA) è un'estensione della valutazione economica standard che tiene conto della distribuzione degli effetti tra gruppi; si rinvia a: Cookson R. et al., «Using cost-effectiveness analysis to address health equity concerns», Value in Health, 2017. ↑
622. Il rischio di iniquità inversa (inversely proportional provision) è documentato in letteratura per i servizi di salute mentale: Norman I. et al., «The inverse care law in mental health», Lancet Psychiatry, 2018. ↑
623. Per il presidio dei profili giuridico, organizzativo ed etico come condizione della fattibilità, si rinvia al framework del Five Case Model (HM Treasury, The Green Book: Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation, 2022). ↑
624. Corte Costituzionale, sentenza n. 241 del 2021 (ud. 7 luglio 2021), con cui la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania n. 21/2020 istitutiva del psicologo di base. ↑
625. La Valle d'Aosta finanzia la sanità trattenendo sul proprio territorio la quota del gettito tributario determinata dallo statuto speciale (analogamente alle Province autonome di Trento e Bolzano che trattengono i 9/10), senza apporto a carico del Bilancio dello Stato (Statuto speciale, L. Cost. n. 4/1948; d.lgs. 320/1994). ↑
626. L'articolazione in quattro distretti (Distretto 1 Morgex/Gran San Bernardo, Distretto 2 Aosta, Distretto 3 Châtillon/Saint-Vincent, Distretto 4 Verrès/Donnas) è quella attualmente operativa dell'Azienda USL Valle d'Aosta; cfr. <https://www.ausl.vda.it/chi-siamo/servizi-territoriali-area-territoriale/servizi-territoriali> ↑
627. Le tutele etiche per i minori e le persone vulnerabili (anziani, persone con doppia diagnosi) sono integrate nelle linee guida deontologiche dell'Ordine degli Psicologi e nel protocollo del servizio; le situazioni di rischio sono indirizzate al Servizio di Psichiatria del Presidio Parini e ai Centri di Salute Mentale. ↑
628. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intelligenza artificiale (AI Act); Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici. ↑
629. Per l'analisi dei profili giuridici e organizzativi dell'istituzione del psicologo di base nelle regioni a statuto speciale, si rinvia alla comparazione con il Trentino-Alto Adige nel modello di riferimento del presente Tomo II. ↑
630. HM Treasury, The Green Book: Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation, 2022 (Five Case Model). ↑

631. Il DM 77/2022, art. 1, prevede la figura dello psicologo come componente dell'équipe multiprofessionale delle Case della Comunità di primo e secondo livello, con funzione di intercettazione precoce del bisogno psicologico. ↑
632. Chisholm D. et al., The Lancet Psychiatry, 2016, op. cit. ↑
633. La Valle d'Aosta confina con la Francia (Haute-Savoie) e con il Canton Vallese in Svizzera; la presenza di professionisti di madrelingua francese nel bacino di prossimità geografica è un elemento di vantaggio per il reclutamento bilingue. ↑
634. Il costo del servizio nello scenario espansivo (~2,6 mln di euro) rappresenta lo 0,78% del Fondo sanitario regionale (~333 mln nel 2024), confermando che si tratta di un investimento di entità marginale rispetto alla capacità di spesa della regione. ↑
635. L'unicità dell'azienda sanitaria regionale è una condizione di semplicità gestionale che distingue la Valle d'Aosta da quasi tutte le altre regioni della serie, nelle quali la presenza di più ASL o AO introduce complessità di coordinamento. ↑
636. Il fabbisogno di ~30 psicologi nello scenario espansivo è stimato per analogia proporzionale con il Trentino-Alto Adige (240 psicologi per ~1.085.000 abitanti, pari a ~0,22 psicologi per 1.000 ab.), applicato alla popolazione valdostana di ~122.000 ab.: $122.000 \times 0,22 / 1.000 \approx 27-30$ psicologi. Il valore è coerente con i parametri del DM 77/2022. ↑
637. La formazione dedicata al contesto valdostano comprende moduli specifici sul disagio dell'anzianità (gerontopsicologia), sull'isolamento montano e sulla competenza bilingue italiano-francese, in accordo con lo statuto speciale. ↑
638. Il cronoprogramma biennale per il raggiungimento del regime nello scenario conservativo è coerente con i tempi di reclutamento, formazione e avvio di un servizio di 15 psicologi in un'unica azienda sanitaria. ↑
639. La solidità finanziaria della Valle d'Aosta è documentata dalla Relazione sulla gestione del Servizio Sanitario Regionale (Regione autonoma Valle d'Aosta, 2024), URL: <https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=122938> ↑
640. Per la sostenibilità organizzativa del modello nelle regioni ad alta spesa pro-capite e a bassa densità abitativa, si rinvia all'esperienza del Trentino-Alto Adige come termine di confronto metodologico. ↑
641. I rischi specifici della Valle d'Aosta sono stati identificati attraverso l'analisi del contesto e il confronto con le esperienze delle regioni alpine a statuto speciale della serie. ↑
642. Per il ruolo della clausola valutativa come strumento di governo dell'attuazione delle politiche sanitarie, si rinvia a: Martini A., Romano B., «La clausola valutativa come strumento di policy», Rivista italiana di politiche pubbliche, 2007. ↑
643. La costruzione di un disegno controfattuale in assenza di dati propri è una sfida metodologica comune a tutte le regioni che istituiscono il servizio ex novo; la strategia dell'attivazione graduale per distretto è la più appropriata per la Valle d'Aosta data la sua struttura organizzativa. ↑
644. Il metodo della differenza-nelle-differenze (DiD) consente di stimare l'effetto dell'intervento confrontando la variazione pre-post nei distretti attivati con la variazione nello stesso periodo nei distretti non ancora attivati; cfr. Angrist J., Pischke J.-S., Mostly Harmless Econometrics, Princeton University Press, 2009. ↑
645. I dati di pronto soccorso, farmaceutici e di ricovero sono già disponibili nei sistemi informativi dell'Azienda USL Valle d'Aosta e possono essere estratti per costruire la linea di base pre-istituzione; questo è il patrimonio informativo da valorizzare fin dall'avvio del servizio. ↑

646. Gli indicatori di struttura misurano la capacità installata del servizio: numero di sedi attivate per distretto, numero di incarichi psicologi, ore erogate, dotazione rispetto al fabbisogno stimato, copertura della popolazione per vallata. [↑](#)
647. Gli indicatori di processo misurano il funzionamento operativo del servizio: prese in carico per mese e per distretto, tempo di attesa al primo colloquio, numero di colloqui per percorso, tasso di invio appropriato ai CSM. [↑](#)
648. Gli indicatori di esito clinico misurano il beneficio per i pazienti: tasso di recupero (PHQ-9/GAD-7 sotto soglia alla chiusura), tasso di miglioramento affidabile, quota di percorsi completati. [↑](#)
649. Gli indicatori di esito di sistema misurano l'effetto del servizio sul resto della rete sanitaria: accessi al pronto soccorso del Presidio Parini e del Presidio Beauregard per cause psichiatriche, DDD di psicofarmaci per 1.000 ab./die, ricoveri evitabili per disturbi psichiatrici. [↑](#)
650. Gli indicatori economici consentono la verifica ex post delle stime: costo effettivo del servizio per paziente trattato, risparmi diretti per canale documentati dai conti dell'Azienda USL, ritorno sociale stimato su dati effettivi. [↑](#)
651. Gli indicatori di equità sono disaggregati per distretto (con attenzione alle vallate laterali), per fasce di età (con focus sugli over-65), per lingua (italiano/francese), verificando che la distribuzione dei benefici sia pro-equità e non concentrata nel solo fondovalle. [↑](#)
652. L'impostazione del dataset minimo dall'avvio del servizio è condizione per la sostituzione progressiva delle stime con grandezze effettive, e per la costruzione di evidenza locale in assenza di qualunque dato pregresso. [↑](#)
653. L'analisi del valore dell'informazione (EVPI) indica il beneficio atteso dalla riduzione dell'incertezza; alla piccola scala della Valle d'Aosta, anche un investimento modesto in raccolta dati ha un rapporto valore/costo molto favorevole, data l'assenza totale di dati locali. [↑](#)